KLİNİK PSİXİATRİYA

Diaqnostika və müalicə standartları

XBT-11 və DSM-5-TR əsasında klinik bələdçi

Dr. Kənan Rəhimov

Bakı, 2026

MÜNDƏRİCAT

MÜQƏDDİMƏ.....1
Oxucuya müraciət.....1
MÜƏLLİF HAQQINDA.....2
GİRİŞ.....3
Bu kitab haqqında.....3
Bu kitab nədir və nə üçün yazıldı.....3
Niyə XBT-11?.....4
Kitabın strukturu.....5
Fəsillərin təşkili və xüsusiyyətləri.....6
Mənbələr və yanaşma.....8
Kitabın istifadə qaydası.....9
Məsuliyyət qeydi.....9
BU KİTAB NİYƏ MƏHZ İNDİ VƏ AZƏRBAYCANDA?.....11
Üç xəttin kəsişməsi.....11
Niyə məhz indi?.....11
Niyə məhz Azərbaycanda?.....12
Bu kitabın hədəf auditoriyası.....13
Yekun.....14
Müəllif və töhfə verənlər.....14
Təşəkkürlər.....15
DÜNYADA PSİXİ SAĞLAMLIQ BÖHRANI: STATİSTİKA, MEYLLƏR VƏ MÜALİCƏ BOŞLUĞU.....16
Qlobal mənzərə.....16
1990–2021-ci illər tendensiyaları.....16
Cədvəl 1. Əsas psixi pozuntuların qlobal yayılma dinamikası, 1990–2021.....17
COVID-19 pandemiyasının təsiri.....18
Yayılma və artım sürəti üzrə ən çox yayılmış pozuntular.....18
Cədvəl 2. Yayılma və artım sürəti üzrə ilk onluq (2021).....18
Müalicə boşluğu fenomeni.....19
Cədvəl 3. Müalicə boşluğu — pozuntular üzrə müqayisə.....20
Psixogen aspekt: kök problem.....21
Yekun.....22
PSİXOPATOLOGİYAYA GİRİŞ.....24
Bu bölmənin məqsədi.....24
Simptom və sindrom anlayışları.....24
Psixopatoloji simptomların təsnifatı.....25
Əsas psixopatoloji sindromlar.....29
KLİNİK MÜSAHİBƏ VƏ PSİXİ STATUSUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.....32
Klinik müsahibənin məqsədləri.....32
Klinik müsahibənin strukturu.....32
Psixi statusun qiymətləndirilməsi.....34
İntihar riskinin qiymətləndirilməsi.....37
Heteroagressiv (başqalarına zərər) riskin qiymətləndirilməsi.....39

HÜQUQİ-ETİK ASPEKTLƏR.....41
Azərbaycan psixiatrik qanunvericiliyinin əsasları.....41
Psixiatriya yardımının növləri.....41
Könüllü psixiatriya yardımı.....42
Qeyri-könüllü hospitallaşdırma.....42
Məcburi tibbi tədbirlər.....44
Klinik psixoloqun hüquqi vəziyyəti.....44
Məxfilik və onun sərhədləri.....46
Yetkinlik yaşına çatmamış pasiyentlər.....47
Aqressiv pasiyent və təhlükəsizlik tədbirləri.....47
Sənəd nümunələri.....49
Etik prinsiplər.....51
PSİXOTERAPİYANIN KLİNİK STRATEGİYALARI.....52
Klinik psixoterapiya konsepsiyası.....52
Psixoterapevtik məktəblər və mexanizmləri.....53
Sübut səviyyələri.....55
Pozuntu üzrə müalicə strategiyalarının xəritəsi.....55
Cədvəl 4. Psixoterapevtik strategiyalar — pozuntu üzrə xəritə.....55
Farmakoterapiya və psixoterapiya: rəqib deyil, tamamlayıcı.....57
Cədvəl 5. Farmakoterapiya və psixoterapiya: müqayisəli imkanlar.....58
Klinik psixoterapiyanın təşkilati əhəmiyyəti.....59
MÜƏLLİF KLİNİK PROTOKOLU №1: UŞAQLARDA GECƏ ENUREZİNİN MÜALİCƏSİ.....60
Protokolun mahiyyəti və yeri.....60
Protokolun klinik prinsipləri.....61
Protokolun mərhələləri.....62
Cədvəl 6. Modifikasiya edilmiş alarm-terapiya protokolu — mərhələlər üzrə.....63
11–12-ci həftə: konsolidasiya və qiymətləndirmə.....66
Çanaq dibi əzələlərinin məşqlərinin (ing. Kegel exercises) təsviri (kompleks gündəlik proqram).....66
Praktik tövsiyələr.....67
Protokolun klinik psixoterapiya çərçivəsində yeri.....69
MÜƏLLİF KLİNİK PROTOKOLU №2: PSİXOGEN DEPRESSİYANIN MÜALİCƏSİ.....70
Protokolun mənası və yeri.....70
Pasiyentin stratifikasiyası.....71
Cədvəl 7. Depressiv pozuntularda müalicə taktikasının seçimi.....71
Cədvəl 8. Farmakoterapiyanın məcburi paralel tətbiqi üçün meyarlar.....72
I HİSSƏ. QISAMÜDDƏTLİ KOGNİTİV-RESTRUKTURLAŞDIRMA (1–6 SEANS)…73
İlkin qiymətləndirmə və xronoloji tarixçə.....73
Autoaqressiv kognitiv quraşdırmanın eyniləşdirilməsi.....74
Kognitiv yenidənqurma — ardıcıl texnikalar.....74
Qısamüddətli mərhələnin nəticəsi.....76
II HİSSƏ. UZUNMÜDDƏTLİ PROFİLAKTİK TERAPİYA — 4 ARDİCİL ETAP.....77
Etap 1. Dərk etmə (ing. insight).....77
Etap 2. Konfrontasiya.....77
Etap 3. Aydınlaşdırma.....78
Cədvəl 8. Reaksiya vermə qütbləri və onların nəticələri.....78
Etap 4. Hərtərəfli işləmə.....80

Uzununa nəticələr....80
Cədvəl 9. Müqayisəli longituidnal nəticələr (20–25 illik müşahidə)....81
Resurs effektivliyi....81
Klinik psixoterapiya çərçivəsindəki yeri....82
AKKREDİTASİYA VƏ KEYFİYYƏT NƏZARƏTİ: BEYNƏLXALQ STANDARTLAR VƏ AZƏRBAYCANDA VƏZİYYƏT....83
Niyə akkreditasiya vacibdir?....83
Beynəlxalq akkreditasiya orqanları və tələbləri....83
Psixoanaliz: International Psychoanalytical Association (IPA)....83
Cədvəl 10. IPA-nın psixoanalitik təlim tələbləri....84
Kognitiv-davranış terapiyası: Avropa Davranış və Kognitiv Terapiyalar Assosiasiyası (ing. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT)....84
Cədvəl 11. EABCT-də Azərbaycan və regionun vəziyyəti....85
Dialektik davranış terapiyası: DBT-Linehan Board of Certification (DBT-LBC)....86
Cədvəl 12. DBT-LBC sertifikatlaşma tələbləri....86
EMDR: EMDR Europe....87
Cədvəl 13. EMDR Europe akkreditasiya səviyyələri....87
Avropa İttifaqında ümumi tənzimləmə vəziyyəti....88
Azərbaycandakı vəziyyət....88
Mütəxəssisi necə fərqləndirmək olar?....89
Kitabın bu şəraitdəki yeri....90
6A00–6A0Z NEYROİNKİŞAF POZUNTULARI....92
6A00 İNTELLEKTUAL İNKİŞAF POZUNTUSU....92
6A01 İNKİŞAF NİTQ VƏ DİL POZUNTULARI....105
6A02 AUTİZM SPEKTRİ POZUNTUSU (ASP)....120
6A03 İNKİŞAF ÖYRƏNMƏ POZUNTUSU....138
6A04 İNKİŞAF HƏRƏKİ KOORDİNASİYA POZUNTUSU (İHKP)....151
6A05 DİQQƏT ÇATIŞMAZLIQ VƏ HİPERAKTİVLİK POZUNTUSU (DDHP)....163
6A06 STEREOTİPİK HƏRƏKƏT POZUNTUSU....180
8A05.0 İLKİN TİKLƏR VƏ YA TİK POZUNTULARI....192
6A20–6A2Z ŞİZOFRENİYA SPEKTRİ....208
6A20 ŞİZOFRENİYA....208
6A21 ŞİZOAFFEKTİV POZUNTU....228
6A22 ŞİZOTİPİK POZUNTU....241
6A23 KƏSKİN VƏ KEÇİCİ PSİXOTİK POZUNTU....251
6A24 SAYIQLAMA POZUNTUSU....262
6A25 İLKİN PSİXOTİK POZUNTULARIN SİMPTOM DOMENLƏRİ....268
6A40 KATATONİYA....273
6A40 BAŞQA BİR PSİXİ POZUNTU İLƏ ƏLAQƏLİ KATATONİYA....273
6A60–6A7Z ƏHVAL POZUNTULARI....281
6A60 I TİP BİPOLYAR POZUNTU....281
6A61 BİPOLYAR POZUNTU TİP II....290
6A62 SİKLOTİMİK POZUNTU....297
6A70 TƏK EPİZODLU DEPRESSİV POZUNTU....301
6A71 TƏKRARLANAN DEPRESSİV POZUNTU....312
6A72 DİSTİMİK POZUNTU....317
GA34.41 PREMENSTRUAL DİSFORİK POZUNTU (PMDP)....323

6B00–6B0Z TƏŞVİŞ VƏ QORXU İLƏ ƏLAQƏLİ POZUNTULAR (XBT-11) 330
6B00 GENERALİZƏ OLUNMUŞ TƏŞVİŞ POZUNTUSU (ÜTP).....330
6B01 PANİK POZUNTU.....338
6B02 AQORAFOBİYA.....343
6B03 SPESİFİK FOBİYA.....348
6B04 SOSİAL TƏŞVİŞ POZUNTUSU.....353
6B05 AYRILMA TƏŞVİŞİ POZUNTUSU.....360
6B06 SELEKTİV MUTİZM.....365
6B20–6B2Z Obsessiv-kompulsiv və əlaqəli pozuntular (OKP).....370
6B20 OBSESSİV-KOMPULSİV POZUNTU (OKP).....370
6B21 BƏDƏN DİSMORFİK POZUNTUSU (BDP).....377
6B22 BƏDƏNİN QOXUSU POZUNTUSU.....382
6B23 HİPOXONDRİYA.....386
6B24 YIĞMA POZUNTUSU.....392
6B25 BƏDƏNƏ YÖNƏLMİŞ TƏKRAR DAVRANIŞLAR POZUNTUSU.....397
6B40–6B4Z STRES İLƏ ƏLAQƏLİ POZUNTULAR.....404
6B40 POSTTRAVMATİK STRESS POZUNTUSU (PTSP).....404
6B41 KOMPLEKS POSTTRAVMATİK STRESS POZUNTUSU (KPTSP).....412
6B42 UZANMIŞ YAS POZUNTUSU.....417
6B43 UYĞUNLAŞMA POZUNTUSU.....423
6B44 REAKTİV BAĞLANMA POZUNTUSU.....428
6B45 SOSİAL QATILMA MƏHDUDLAŞMASI POZUNTUSU.....433
6B60–6B6Z DİSSOSİATİV POZUNTULAR.....439
6B60 DİSSOSİATİV NEVROLOJİ SİMPTOM POZUNTUSU.....439
6B61 DİSSOSİATİV AMNEZİYA.....444
6B64 DİSSOSİATİV İDENTİFİKASİYA POZUNTUSU (DİP).....448
6B65 PARSİAL DİSSOSİATİV İDENTİFİKASİYA POZUNTUSU.....454
6B66 DEPERSONALİZASİYA-DEREALİZASİYA POZUNTUSU.....458
6B80–6B8Z Qida qəbulu pozuntuları (yemə pozuntuları).....463
6B80 SİNİR ANOREKSİYASI.....463
6B81 SİNİR BULİMİYASI.....469
6B82 AŞIRI QİDALANMA POZUNTUSU.....474
6B83 QAÇINAN-MƏHDUDLAŞDIRICI QİDA QƏBULU POZUNTUSU.....478
6B84 PİKA.....483
6B85 RUMİNASİYA-REQURGİTASİYA POZUNTUSU.....487
6C00–6C0Z İFRAZAT POZUNTULARI.....491
6C00 ENUREZ.....491
6C01 ENKOPREZ.....496
6C20 BƏDƏNİ ƏZAB-ƏZİYYƏT.....502
6C20 BƏDƏN DİSTRESSİ POZUNTUSU.....502
6C40–6C5Z MADDƏ İLƏ ƏLAQƏLİ.....507
6C40 ALKOQOL QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR.....507
6C41 KANNABİNOİDLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR.513
6C43 OPİOİDLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR.....517
6C44 SEDATİV, HİPNOTİK VƏ YA ANKSİOLİTİK MADDƏLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR.....523

6C45 KOKAİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR....527
6C46 AMFETAMİN, METAMFETAMİN VƏ YA METKATİNON DA DAXİL OLMAQLA STİMULYATOR MADDƏLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR....531
6C49 HALLÜSİNOGENLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR 536
6C4A NİKOTİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR....540
6C50 QUMAR OYNAMA POZUNTUSU....545
6C51 OYUN OYNAMA POZUNTUSU....549
6C70–6C7Z İMPULS NƏZARƏTİ POZUNTULARI....587
6C70 PİROMANİYA....587
6C71 KLEPTOMANİYA....591
6C72 KOMPULSİV CİNSİ DAVRANIŞ POZUNTUSU....594
6C73 EPİZODİK EKSPLOSİV POZUNTU (EEP)....599
6C90–6C9Z DAĞIDICI DAVRANIŞ VƏ YA DİSSOSİAL POZUNTULAR...604
6C90 MÜXALİF-İNADKAR POZUNTU (MİP)....604
6C91 DAVRANIŞ-DİSSOSİAL POZUNTU....608
6D10–6D1Z ŞƏXSİYYƏT POZUNTULARI....615
6D10 ŞƏXSİYYƏT POZUNTUSU....615
6D11 QABARIQ ŞƏXSİYYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ YA REAKSİYALARI....621
6D30–6D3Z PARAFİLİK POZUNTULAR....625
6D30 EKSHİBİSİONİST POZUNTU....625
6D31 VOYEURİSTİK POZUNTU....628
6D32 PEDOFİLİK POZUNTU....631
6D33 MƏCBURİ CİNSİ SADİZM POZUNTUSU....636
6D34 Frotterist pozuntu (ing. frotteuristic disorder)....640
6D50–6D5Z Süni pozuntular....643
6D50 ÖZÜNƏ TƏTBİQ EDİLƏN SÜNİ POZUNTU (faktisioz)....643
6D51 BAŞQASINA TƏTBİQ EDİLƏN SÜNİ POZUNTU....647
6D70–6D8Z NEYROKOQNİTİV POZUNTULAR....652
6D70 DELİRİUM....652
6D71 YÜNGÜL NEYROKOQNİTİV POZUNTU....657
6D72 AMNESTİK POZUNTU....662
6D80 ALZHEİMER XƏSTƏLİYİ NƏTİCƏSİNDƏ DEMENSİYA....666
6D81 SEREBROVASKULYAR XƏSTƏLİK NƏTİCƏSİNDƏ DEMENSİYA....673
6D82 LEWY CİSİMCİKLƏRİ XƏSTƏLİYİ NƏTİCƏSİNDƏ DEMENSİYA....678
6D83 FRONTOTEMPORAL DEMENSİYA (FTD)....683
6E20–6E2Z PERİNATAL POZUNTULAR....688
6E20 HAMİLƏLİK, DOĞUŞ VƏ YA DOĞUŞDAN SONRAKI DÖVR İLƏ ƏLAQƏLİ PSİXİ VƏ YA DAVRANIŞ POZUNTULARI, PSİXOTİK SİMPTOMSUZ....688
6E21 HAMİLƏLİK, DOĞUŞ VƏ YA ZAHILIQ DÖVRÜ İLƏ ƏLAQƏLİ PSİXİ VƏ YA DAVRANIŞ POZUNTULARI, PSİXOTİK SİMPTOMLARLA....694
6E40 PSİXOLOJİ VƏ DAVRANIŞ AMİLLƏRİ....700
6E40 BAŞQA YERDƏ TƏSNİF EDİLƏN POZUNTULARA VƏ YA XƏSTƏLİKLƏRƏ TƏSİR EDƏN PSİXOLOJİ VƏ YA DAVRANIŞ AMİLLƏRİ....700
6E60–6E6Z İKİNCİ DƏRƏCƏLİ PSİXİATRİYA....705
6E61 İKİNCİ DƏRƏCƏLİ PSİXOTİK SİNDROM....705

6E62 İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ƏHVAL-RUHİYYƏ SİNDROMU....710
6E63 İKİNCİLİ TƏŞVİŞ SİNDROMU....714
YUXU-OYANIQLIQ POZUNTULARI (Sleep-wake disorders)....717
7A00 XRONİKİ İNSOMNİYA....717
7A20 NARKOLEPSİYA....722
7A41 OBSTRUKTİV YUXU APNOESİ....726
7A60–7A65 GECİKMİŞ TİPLİ YUXU-OYANIQLIQ FAZALARIN POZUNTUSU....730
7A21–7A26 İDİOPATİK HİPERSOMNİYA....734
HA00–HA0Z CİNSİ SAĞLAMLIQ....738
HA01.1 KİŞİ EREKTİL DİSFUNKSİYASI....738
HA03.0 KİŞİLƏRDƏ ERKƏN EYAKULYASİYA....742
HA00 HİPOAKTİV CİNSİ İSTƏK DİSFUNKSİYASI....747
HA02.0 ANORQAZMİYA....751
HA20 Ağrılı penetrasiya cinsi pozuntusu (ing. Sexual pain-penetration disorder)....756
HA40 CİNSİ DİSFUNKSİYALARDA VƏ CİNSİ AĞRI POZUNTULARINDA ETİOLOJİ MÜLAHİZƏLƏR....760
ƏLAVƏLƏR....765
ƏLAVƏ A....766
MONİTORİNQ VƏ MÜAYİNƏ STANDARTLARI....766
A.1. Antipsikotik terapiyada metabolik monitorinq....766
A.2. Litium monitorinqi....767
A.3. Antiepileptiklər (valproat, karbamazepin, lamotrigin)....768
A.4. SSGİ və SNGİ monitorinqi....769
A.5. Benzodiazepin istifadəsi....769
A.6. Psixoterapiya monitorinqi....770
ƏLAVƏ B....771
NEYROİNKİŞAF POZUNTULARININ SKRİNİNQ ŞKALALARI....771
B.1. M-CHAT-R: Autizm spektri üzrə dəyişdirilmiş yoxlama siyahısı, yenidən işlənmiş (ing. Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) – 16–30 aylıq uşaqlar üçün...771
B.2. AQ-10 (Autizm Spektri Kvotienti-10): qısa autizm spektri qiymətləndirməsi (16 yaş və yuxarı)....776
B.3. ASRS v1.1: Yetkin DDHP üzrə Özünü Bildirmə Şkalası....778
B.4. SNAP-IV: Swanson, Nolan və Pelham Qiymətləndirmə Şkalası (uşaqlarda DDHP) 782
B.5. İntellektual və adaptiv qiymətləndirmənin əsas alətləri (məlumat cədvəli)....788
Müəllifin qeydi....791
ƏLAVƏ C....792
PSİXİATRİK TƏCİLİ VƏZİYYƏTLƏR....792
C.1. Aktiv intihar (suisid) riski....792
C.2. Delirium tremens və alkoqol çəkilmə sindromu....793
C.3. Serotonin sindromu....794
C.4. Neyroleptik malign sindrom (NMS)....794
C.5. Kəskin distoniya....795
C.6. Kəskin maniya və psixomotor ajitasiya....795
C.7. Kəskin psixoz....796
C.8. Katatoniya....796
ƏLAVƏ D....797
HƏRBİ-TİBBİ EKSPERTİZA (AZƏRBAYCANDA)....797

D.1. Hüquqi əsas....797
D.2. Psixiatrik qiymətləndirmə strukturu....797
D.3. Psixiatrik pozuntular və hərbi xidmətə yararlılıq qiymətləndirilməsi....798
D.4. Veteranların qiymətləndirilməsi və döyüş travması....799
ƏLAVƏ E....800
ƏLAQƏLİ NEVROLOJİ VƏZİYYƏTLƏR....800
E.1. Epilepsiya (8A60–8A6Z) və psixiatrik təzahürlər....800
E.2. Baş ağrısı və psixiatrik komorbidlik....800
E.3. Beyin-qan damar xəstəlikləri (insult)....801
E.4. Parkinson xəstəliyi....801
E.5. Multipl skleroz (MS)....802
E.6. Travmatik beyin zədəsi (TBZ)....802
E.7. Demensiya (ətraflı Bölmə 17-də)....802
E.8. Tutmalar, hərəkət pozuntuları və psixiatriya....803
ÜMUMİ MƏNBƏLƏR VƏ ƏDƏBİYYAT....804
Əsas XBT-11 və DSM-5 mənbələri....804
Klinik psixiatriya dərslikləri....804
Azərbaycan dilində mənbələr....804
Praktik klinik qaydalar (guidelines)....805
Əsas resenzə olunan (peer-review) jurnallar....805
Onlayn resurslar....806
YEKUN TÖVSİYƏLƏR....807
Diaqnoz həmişə ikinci addımdır, birinci deyil....807
Psixoterapiya əksər hallarda birinci seçimdir....807
Minimum effektiv doza prinsipi....808
Mədəni kontekstlə iş....808
Skrininq ilkin səhiyyədə standart olmalıdır....808
İntihar riskinin qiymətləndirilməsi....808
Komorbidlik qaydadır, istisna deyil....809
Yaş və inkişaf mərhələsi nəzərə alınmalıdır....809
Multidissiplinar komanda — effektiv klinik işin əsasıdır....810
Etik və hüquqi çərçivə....810
Həkimin öz sağlamlığına diqqəti....810
Davamlı təhsil və inkişaf....811

MÜQƏDDİMƏ

Oxucuya müraciət

Hörmətli həkim, klinik psixoloq, psixoterapevt, psixiatriya rezidenti və tələbə!

Bu kitab mövcud boşluqdan doğulmuşdur. İyirmi üç illik klinik təcrübədə eyni maneə ilə dəfələrlə rastlaşmaq lazım gəlmişdir: diaqnoz aydındır — amma onu təsdiqləyən meyarlar bir mənbədə, müayinə ardıcıllığı başqasında, müalicə sxemi üçüncüsündə, proqnoz isə heç yerdə. Hər pasiyent üçün bu yolu yenidən keçmək lazım gəlirdi.

Axtarış vəziyyəti yüngülləşdirmək əvəzinə ağırlaşdırdı. Birinci səhifədə köhnəlmiş təsnifat, dərman şirkətinin bukleti və heç bir sübutu olmayan «müəllif metodu» yan-yana dayanır. Hansının arxasında tədqiqat var, hansının yalnız marketinq — bunu ayırd etmək üçün əlavə saatlar lazımdır. Kabinetdə isə o saatlar yoxdur: pasiyent qarşınızda oturmuşdur və cavabı elə indi gözləyir. Rezidentləri öyrədəndə bunu daha aydın gördüm — səhv qərar çox vaxt biliksizlikdən yox, ilk tapılan mənbəyə etibardan doğur.

Hazır həll uzun müddət axtarılsa da, tapılmadı. Tapmadım — və yazmalı oldum. Kitabın bütün quruluşu bir prinsipdən çıxır: hər pozuntu üçün vahid strukturlaşdırılmış bölmə. Meyarlar, differensial diaqnostika, müayinə, müalicə, proqnoz və ən yayılmış miflər bir yerdə, üç təsnifatın kodları ilə və hər iddianın arxasında adı çəkilən mənbə ilə. Buraya yalnız sübutu yoxlanıla bilən məlumat daxil edilmişdir.; qalanı isə mifə çevrildiyi üçün ayrıca bölmədə açıq adlandırılır.

Sizin əlinizdəki «Klinik Psixiatriya: Diaqnostika və terapiya standartları» Azərbaycan dilində sistemli klinik psixiatriya istinad bələdçisidir. O, başdan-sona oxunmaq üçün deyil, işlənmək üçün yazılmışdır: pasiyent qarşınızda oturub, sizin isə on dəqiqəniz var. Bütün fəsillər eyni cür qurulub — dəyişməyən ardıcıllıqla səkkiz bölmə — ki, axtardığınız məlumatı uzun-uzadı axtarmaq lazım gəlməsin.

Kitab XBT-11 üzərində qurulmuşdur. 2022-ci ildə qüvvəyə minən bu təsnifat yalnız kodları dəyişmədi: şəxsiyyət pozuntusuna baxışı, travma anlayışını və üzvi ilə funksional arasındakı köhnə sərhədi yenidən yazdı. Bununla belə, post-sovet klinik məktəbinin — Popov və Vid ənənəsinin — təsiri saxlanılmışdır. Beynəlxalq təlimatın güclü olduğu yerdə ona istinad edilir; klassik məktəbin daha dəqiq olduğu yerdə isə məhz onun yanaşması əsas götürülür. Fərqlər ört-basdır edilmir, açıq adlandırılır.

Buradakı iki protokol — uşaqlarda gecə enurezinin müalicəsi və psixogen depressiyada iki mərhələli strategiya — müəllifin öz klinik təcrübəsinə əsaslanır. Onlar beynəlxalq təlimatların modifikasiyasıdır və sübut səviyyələri IV-dür: ekspertin klinik təcrübəsi, randomizə olunmuş tədqiqat deyil. Bunu açıq yazıram ki, oxucu nəyə söykəndiyini bilsin. Yoxlayın, mübahisə edin, öz praktikanızda sınayın.

Bu kitab son söz kimi qəbul edilməməlidir. Psixiatriya sürətlə dəyişdiyi üçün buradakı məlumat müntəzəm yenilənməlidir. Səhv görsəniz, mənə yazın. Növbəti nəşr sizin qeydlərinizlə daha yaxşı olacaq.

MÜƏLLİF HAQQINDA

Bu kitabın müəllifi Kənan Rəhimov — həkim-psixiatr və psixoterapevtdir, klinik təcrübəsi 23 ildir (2003-cü ildən). Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini 2001-ci ildə bitirmişdir, həmin il Bakıdakı 2 saylı Klinik Psixiatriya Xəstəxanasında internaturanı keçmişdir. 2001–2003-cü illərdə Sankt-Peterburqdakı V.M. Bexterev adına Psixonevroloji Elmi-Tədqiqat İnstitutunda klinik ordinaturanı fərqlənmə diplomu ilə tamamlamışdır — Rusiya Federasiyasının Baş Psixoterapevti, professor B.D. Karvasarskinin rəhbərliyi altında nevrozların psixoterapiyası şöbəsində və Beynəlxalq Psixoanalitik Assosiasiyası (IPA) tərəfindən sertifikatlaşdırılmış postsovet məkanının ilk diplomlu psixoanalitiklərindən biri olan professor V.D. Vid-in rəhbərliyi altında psixozların psixoterapiyası şöbəsində tamamlanmışdır. 23 illik klinik praktika ərzində depressiv pozuntusu olan 1 000-dən çox pasiyent və gecə enurezi diaqnozu qoyulmuş 1000-dən çox uşaq müalicə edilmişdir; 2025-ci ildə müəllifin klinik komandası 250-dən çox uşağı müalicə etmişdir. 2020-ci ildən RAGIMOFF Peşəkar Psixologiya Məktəbinin təsisçisi, 2021-ci ildən Sankt-Peterburqdakı Karvasarski adına İnstitutunun Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi və Klinik Psixologiya üzrə Əlavə Peşə Təhsili (ƏPT) proqramının rəhbəri, 2022-ci ildən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının (IPAS) səlahiyyətli nümayəndəsidir. Bu kitabda təqdim olunan iki müəllif klinik protokolu — uşaqlarda gecə enurezinin müalicəsi və psixogen depressiyanın iki mərhələli müalicə strategiyası — beynəlxalq sübuta əsaslanan təlimatların (NICE, APA, WFSBP) müəllifin uzunmüddətli klinik təcrübəsi və retrospektiv klinik müşahidələri əsasında modifikasiyasını əks etdirir. Bu modifikasiyalar standart beynəlxalq protokollarla müqayisədə daha qısa müddətdə daha yüksək klinik effektivliyə nail olmaq imkanı verir; sübut səviyyəsi IV (klinik ekspert təcrübəsi) qəbul edilməlidir. Müəllifin tövsiyələri klinik ekspertizadan və 23 illik fasiləsiz praktikadan irəli gəlir; oxucu özü öz klinik təcrübəsində bu yanaşmaları yoxlaya, qiymətləndirə və lazım gələrsə uyğunlaşdıra bilər.

GİRİŞ

Bu kitab haqqında

Bu kitab klinik psixiatriyanın müasir standartları üzrə Azərbaycan dilində ilk sistematik təqdimatdır. Kitab Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatının 11-ci yenidən baxışı (XBT-11) əsasında qurulmuşdur və onun strukturunu, diaqnostik meyarlarını, müalicə yanaşmalarını Azərbaycan klinik ənənəsinə və post-sovet psixiatrik məktəbinə uyğun şəkildə inteqrasiya edir.

Kitab praktik həkimlər üçün — psixiatr, psixoterapevt, nevroloq, ilkin səhiyyə həkimi, klinik psixoloq, tibbi təhsilin son kurs tələbələri və rezidentlər üçün — istinad bələdçisi kimi hazırlanmışdır.

Bu kitab nədir və nə üçün yazıldı

Bu kitab klinik istinad bələdçisidir, nəzəri psixiatriya dərsliyi deyil. Burada hər bir psixi pozuntu üzrə diaqnostik meyarlar, klinik təzahürlər və müalicə protokolları standartlaşdırılmış formatda təqdim olunur. Hər bir mövzunun ətraflı patofizioloji, neyrobioloji və ya tarixi izahı — bu kitabın hədəfi deyil; məqsəd — həkimə xəstə qarşısında lazımi məlumatı tez və dəqiq tapmağa imkan verməkdir.

Kitabın yazılma səbəbləri:

- Azərbaycan dilində müasir psixiatriya istinad bələdçisi yoxdur. Mövcud azərbaycandilli ədəbiyyat – əksərən tərcümə işləri və ya XX əsrin sonu məktəbinə əsaslanan dərsliklərdir. XBT-11 (2022-ci ildən qüvvədə) və DSM-5-TR (2022) yenilikləri Azərbaycan dilində sistemli şəkildə əks olunmamışdır.
- Diaqnostik təsnifatların vahid sistemə gətirilməsi. Klinik təcrübədə həkimlər həm XBT-10 (Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hələ də rəsmi statistika üçün istifadə olunan), həm XBT-11 (yeni standart), həm də DSM-5-TR (beynəlxalq elmi nəşrlərdə üstünlük təşkil edən təsnifat) ilə qarşılaşırlar. Bu kitabda hər üç sistem paralel şəkildə təqdim olunur ki, həkim müxtəlif kontekstlərdə düzgün koddan və terminologiyadan istifadə edə bilsin.
- Azərbaycan rəsmi klinik protokollarının inteqrasiyası. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi (İSİM) tərəfindən hazırlanmış və Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş rəsmi klinik protokollar ((Şizofreniya, 2009; Təşviş pozuntuları, 2013; OKP, 2015; Depressiya, ili göstərilməklə)) bu kitabın yerli klinik bazasını təşkil edir. Beynəlxalq tövsiyələr (Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Sosial Xidmətlər

üzrə Milli İnstitutu — NICE, Amerika Psixiatriya Assosiasiyası — APA, Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyası — WFSBP, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı — ÜST) və Azərbaycan rəsmi protokolları arasındakı uyğunluqlar və fərqlər ayrıca qeyd edilmişdir.

- Hüquqi-etik istiqamətləndirmə. «Psixiatriya yardımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu və «Psixoloji yardım haqqında» Qanunu çərçivəsində həkimin hüquq və vəzifələri — həm həkim-psixiatr, həm də klinik psixoloq üçün — ayrıca bölmədə təqdim olunmuşdur. İntihar (suisid) fikri olan pasiyentlə davranış, qeyri-könüllü xəstəxanaya yerləşdirmə əsasları, məcburi tibbi tədbirlərin tətbiqi qaydaları – cavab tələb edən real klinik vəziyyətlərdir. Bu kitab onlara cavab verir.

Niyə XBT-11?

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) XBT-11-i 2019-cu ildə qəbul etdi və 2022-ci ildən onun rəsmi tətbiqi başladı. XBT-11 psixi pozuntular fəslində dərin paradiqma dəyişiklikləri gətirmişdir:

- Kompleks posttravmatik stress pozuntusu (PTSP) (6B41) – yeni rəsmi diaqnoz;
- Uzanmış kədər pozuntusu (6B42) — XBT-11-ə əlavə edilmiş müstəqil diaqnoz;
- Şəxsiyyət pozuntularının kateqoriyalar üzrə sistemdən ölçülü (dimensiyal) sistemə keçid — əsas konseptual yenilik;
- Somatoform pozuntuların bədən sıxıntısı pozuntusu (ing. bodily distress disorder, BDD) ilə əvəzlənməsi;
- Cinsiyyət uyğunsuzluğunun (ing. gender incongruence) psixiatrik fəsildən çıxarılması;
- Oyun pozuntusu (ing. gaming disorder) rəsmi diaqnoz kimi müəyyən edilmişdir;
- Kompulsiv cinsi davranış pozuntusu (ing. compulsive sexual behaviour disorder, CSBD) yeni kateqoriya kimi əlavə edilmişdir;
- Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusunun (DÇHP) neyroinkişaf pozuntuları qrupuna köçürülməsi;
- Hipoxondriyanın obsesif-kompulsiv və əlaqəli pozuntular qrupuna yerləşdirilməsi;
- Üzvi və funksional ikili bölgünün ləğvi.

Bu dəyişikliklər həm nozologiyada, həm də müalicə standartlarında yenidən qiymətləndirmə tələb edir.

Kitabın strukturu

Kitab iki əsas hissədən ibarətdir:

I HİSSƏ – Giriş bölmələri:

- Müqəddimə (bu bölmə)
- Mündəricat — XBT-11 strukturuna uyğun iyerarxiya əsasında qurulmuşdur
- Psixopatologiyaya giriş – simptomlar və sindromların təsviri (idrak, qavrayış, təfəkkür, əhval, davranış, yaddaş, iradə, şüur)
- Klinik müsahibə və psixi statusun qiymətləndirilməsi – klinik protokol qaydası, psixi statusun təsviri standartları
- Hüquqi-etik aspektlər – Azərbaycan qanunvericiliyi əsasında həkim-psixiatr və klinik psixoloq üçün praktik istiqamətləndirmə, sənəd nümunələri

II HİSSƏ – Psixi pozuntular (XBT-11 strukturuna uyğun):

XBT-11-in 6-cı fəslindəki bütün 21 əsas qrup ayrı bölmələrdə təqdim olunur. Hər bölmə üçün eyni standart struktur saxlanılır:

- Tərif və nozologiya (qısa)
- Etiologiya
- Epidemiologiya
- Klinik təzahürlər
- Diaqnoz (XBT-11 → XBT-10 → Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı, DSM-5-TR — paralel müqayisə)
- Differensial diaqnoz
- Müayinə üsulları (klinik, laboratoriya və instrumental)
- Müalicə (sübuta əsaslanan tövsiyə dərəcələri ilə)
- Proqnoz
- Mənbələr

Sonda – Mənbələr və Əlavələr:

- İstifadə olunmuş bütün mənbələrin tam siyahısı (Azərbaycan, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ölkələri, beynəlxalq mənbələr)
- Klinik şkalalar və anketlər (Sağlamlıq sorğusu anketi — PHQ-9, Ümumi təşviş pozuntusu şkalası — ÜTP-7, PTSP yoxlama siyahısı — PCL-5, Edinburq postnatal depressiya şkalası — EPDS, Yel-Braun obsesif-kompulsiv şkalası — Y-BOCS, Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası (C-SSRS) və digərləri)

- Psixiatrik təcili vəziyyətlər (alqoritm)
- Hərbi-tibbi qiymətləndirmə qaydaları (Azərbaycanda)

Fəsillərin təşkili və xüsusiyyətləri

Fəsillərin təşkili

Hər klinik fəsil 11 bölmədən ibarətdir:

- Tərif və qısa təsvir – pozuntunun mahiyyəti, XBT-11 yenilikləri;
- Epidemiologiya – yayılma, cins, yaş, komorbidlik;
- Etiologiya və patogenez – bioloji, psixoloji, sosial amillər, Popov-Vid yanaşması;
- Diaqnostik meyarlar – XBT-11 Klinik təsvirlər və diaqnostik təlimatlar (KTTD), XBT-10, DSM-5-TR — müqayisəli;
- Klinik formalar (lazım olduqda) və ya klinik təzahürün xüsusiyyətləri;
- Diferensial diaqnostika – cədvəl formatında;
- Müayinə və qiymətləndirmə – klinik müsahibə, tarama şkalaları, laboratoriya;
- Müalicə – ümumi strategiya, fazalı yanaşma, psixoterapiya, farmakoterapiya, xüsusi klinik vəziyyətlər;
- İzləmə və proqnoz;
- Mənbələr – XBT-11 KTTD 2024, APA, NICE, WFSBP, ISTSS, ISSTD və digər beynəlxalq klinik tövsiyələr;
- Tarixi konsepsiyalar – klassik anlayışlardan müasir yanaşmaya keçid.

Terminologiya

Psixiatrik terminologiya Azərbaycan dilində sistemləşdirilmişdir. Bir çox termin klassik rus-sovet psixiatriyasından gələn uyğunlaşmaları əks etdirir, çünki Azərbaycanda psixiatrik təhsil ənənəvi olaraq rus dilində formalaşmışdır. Beynəlxalq terminlər ingilis dilində, mötərizədə «ing.» qeydi ilə verilir (terminoloji aydınlıq məqsədi ilə).

Popov-Vid məktəbinin inteqrasiyası

Yu.V. Popov və V.D. Vid «Müasir klinik psixiatriya» (Sankt-Peterburq: Reç, 2006, 2-ci nəşr) – post-sovet klinik psixiatriyasının klassik dərsliyidir. Onların metodu — klassik nozologiya, biopsixososial model və praktik klinik təcrübə – müasir

beynəlxalq tövsiyələrlə uyğun olduğu yerlərdə bu kitaba inteqrasiya edilmişdir. Fərqlər olan yerlərdə (məs. XBT-11-in ölçülü (dimensiyal) şəxsiyyət modeli) bu açıq şəkildə göstərilir.

Müalicə standartları

Hər pozuntu üçün müalicə beynəlxalq klinik tövsiyələrə istinad edilir:

- Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA) klinik təcrübə tövsiyələri;
- Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Sosial Xidmətlər üzrə Milli İnstitutu (NICE);
- Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyası (WFSBP);
- Kanada Əhval və Təşviş Pozuntularının Müalicəsi Şəbəkəsi (CANMAT)/Beynəlxalq Bipolyar Pozuntular Cəmiyyəti (ISBD) — bipolyar affektiv pozuntu;
- Travmatik Stressin Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Cəmiyyət (ISTSS);
- Travma və Dissosiasiyanın Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Cəmiyyət (ing. International Society for the Study of Trauma and Dissociation, ISSTD);
- Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyası (AACAP);
- Milli dərman siyahıları və təlimatlar.

Dərman adları həm beynəlxalq qeyri-patent adı (BQPA; ing. international nonproprietary name — INN), həm də ticari (ing. brand) adda verilir, çünki Azərbaycan bazarında dərmanlar əksərən ticari adla tanınır.

Azərbaycan klinik konteksti

Hər uyğun yerdə Azərbaycan kontekstinə spesifik qeydlər verilir:

- Birincili səhiyyədə tətbiq məsələləri;
- Mədəni xüsusiyyətlər və damğalama (ing. stigma);
- Hüquqi-etik çərçivələr;
- Mövcud resursların məhdudluğu;
- İkinci Qarabağ müharibəsi veteranlarında travma pozuntuları;
- Azərbaycan dilində etibarlılığı təsdiqlənmiş alətlər.

Şkalalar və alətlər

Əlavə B-də ən çox istifadə olunan skrininq və qiymətləndirmə alətləri tam mətn şəklində (açıq lisenziyalı) və ya təsvir olaraq (kommersiya məqsədli) təqdim olunur.

Mənbələr və yanaşma

Nüfuzlu mənbələrin prioritet ardıcıllığı. Hər bir mövzu üzrə bir əsas avtoritet bələdçi birinci sırada təqdim olunur, sonra digər bələdçilər müqayisə və ya tamamlama üçün gətirilir. Bu yanaşma akademik dəqiqliklə konkretlik arasında tarazlıq saxlamaq və məlumat təkrarlığından qaçmaq məqsədi daşıyır. Hər bir pozuntu üzrə əsas avtoritet bələdçi seçimləri:

- Şizofreniya: NICE CG178 (2014, 2019 yenilənməsi) + Azərbaycan Respublikası (AR) Səhiyyə Nazirliyinin Klinik Protokolu (2009)
- Depressiya: Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Sosial Xidmətlər üzrə Milli İnstitutu (NICE) NG222 (2022) — «Böyüklərdə depressiyanın müalicəsi və idarə olunması» təlimatı + AR Səhiyyə Nazirliyi Klinik Protokol + APA Practice Guideline (2010)
- Bipolyar pozuntu: CANMAT/ISBD (2018, 2021 yenilənməsi)
- Təşviş pozuntuları: NICE Clinical Guideline 113 (2011/2020). «Böyüklərdə generalizə olunmuş təşviş pozuntusu və panik pozuntu: idarəetmə». NICE CG113 (2011) + AR Səhiyyə Nazirliyi Klinik Protokol (2013) + WFSBP (2012)
- OKP: NICE Clinical Guideline 31 (2005). «Obsessiv-kompulsiv pozuntu və bədən dismorfik pozuntusu». NICE CG31 (2005, qüvvədə) + AR Səhiyyə Nazirliyi Klinik Protokol (2015) + APA (2007)
- PTSP: NICE NG116 (2018) + ISTSS Prevention and Treatment Guidelines (2019)
- Yemə pozuntuları: NICE Guideline 69 (2017). «Yemə pozuntuları: tanınma və müalicə». NICE NG69 (2017) + APA (2023)
- Şəxsiyyət pozuntuları: NICE Clinical Guideline 78 (2009). «Sərhəd şəxsiyyət pozuntusu: tanınma və idarəetmə». NICE CG78 (sərhəd şəxsiyyət pozuntusu, 2009), CG77 (antisosial şəxsiyyət pozuntusu, 2009) + APA (2024)
- Neyroinkişaf pozuntuları: AACAP Practice Parameters + NICE (CG72 — Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu; NG87 — autizm spektri pozuntusu)
- Psixoaktiv maddələrin istifadəsi pozuntuları: NICE NG215 (alkohol) + Amerika Asılılıq Tibb Cəmiyyəti (ASAM) standartları (2020)
- Demensiya: NICE Guideline 97 (2018). «Demensiya: demensiyalı şəxslərin və onlara qulluq edənlərin qiymətləndirilməsi, idarəedilməsi və dəstəyi». NICE NG97 (2018)

Yerli avtoritet mənbələr:

1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi (İSİM) tərəfindən hazırlanmış və Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş klinik protokollar
2. «Psixiatriya yardımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu (sonrakı dəyişikliklərlə)
3. «Psixoloji yardım haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

MDB və post-sovet məkanı:

- Popov Yu.V., Vid V.D. *Müasir klinik psixiatriya* Sankt-Peterburq, 2-ci nəşr, Sankt-Peterburq: Reç, 2-ci nəşr, 2006 — klinik psixiatriyanın klassik post-sovet mənbəyi kimi nəzərə alınmışdır.

Kitabın istifadə qaydası

Tipik klinik istifadə:

- Pasiyentdə müəyyən psixi pozuntudan şübhələndikdə, mündəricatdan müvafiq bölmə tapılır.
- Diaqnoz (5-ci bölmə) — XBT-11 meyarları ilə qiymətləndirmə aparılır.
- Differensial diaqnoz (6-cı bölmə) – cədvəldən digər ehtimalların istisnası.
- Müayinə metodları (7-ci bölmə) – plan tərtib edilir.
- Müalicə (8-ci bölmə) — sübut dərəcəsi göstərilməklə tövsiyələr verilir.

Tələbə üçün:

- Mündəricatdan dərs mövzusu axtarılır.
- Hər bölmədə Tərif → Etiologiya → Epidemiologiya → Klinik təzahürlər → Diaqnoz ardıcıllığı izlənilir.
- Hüquqi-etik aspektlər bölməsindən qanunvericilik məsələləri öyrənilir

Klinik psixoloq üçün:

1. Hüquqi-etik aspektlər bölməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır (məcburi hospitallaşdırma şərtləri, psixoloji yardımın hədləri)
2. Diaqnostik bölmələr həkim-psixiatra yönləndirmə qərarı vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Məsuliyyət qeydi

Bu kitab klinik istinad-bələdçidir, lakin konkret pasiyentdə qərar qəbul etmə zamanı:

- Pasiyentin fərdi klinik mənzərəsi mütləq nəzərə alınmalıdır

- Müalicə qərarları — pasiyentin razılığı, komorbidlikləri, dərmanın yerli mövcudluğu nəzərə alınmaqla qəbul edilməlidir
- Dərman dozaları – yerli istifadə təlimatları Dərman dozaları — yerli istifadə təlimatları ilə təsdiq edilməlidir. ilə təsdiq edilməlidir
- Hüquqi-etik məsələlərdə müvafiq qanunvericiliyin qüvvədə olan son mətni yoxlanılmalıdır.
- Bu kitab fərdi tibbi məsləhəti əvəz etmir

Sahə üzrə biliklər mütəmadi yenilənir;; həkim beynəlxalq və yerli tövsiyələrin yeniliklərini izləməlidir.

BU KİTAB NİYƏ MƏHZ İNDİ VƏ AZƏRBAYCANDA?

Üç xəttin kəsişməsi

Bu Müqəddimənin əvvəlki bölmələrində üç ayrı, lakin bir-biri ilə dərin əlaqəli istiqamət müəyyən edilmişdir:

Birinci xətt — qlobal psixi sağlamlıq böhranı. Dünyada 1 milyarddan çox insan psixi pozuntu ilə yaşayır. Təşviş və depressiya pozuntuları son 30 ildə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu pozuntuların əksəriyyətində psixososial amillər mərkəzi rol oynayır və bu pozuntuların əsas müalicəsi keyfiyyətli psixoterapiyaya əsaslanır. Lakin müalicə boşluğu — xüsusilə təşviş və depressiyada — 70–90 % səviyyəsindədir.

İkinci xətt — sübuta əsaslanan klinik psixoterapiya. Müasir tibb sübuta əsaslanan müdaxilələr üzərinə qurulmuşdur. Hər pozuntu üçün artıq aydın klinik strategiyalar mövcuddur, sübut səviyyələri (A/B/C) müəyyən edilmişdir, beynəlxalq təlimatlar (NICE, APA, ÜST-ün Psixi Sağlamlıq üzrə Fəaliyyət Proqramı (ing. mhGAP), WFSBP) sistematik şəkildə yenilənir. Klinik psixoterapevt — terapevtin əsas məktəbindən asılı olmayaraq — konkret pozuntu üçün ən səmərəli strategiyanı tətbiq etməyə borcludur.

Üçüncü xətt — peşə standartları və akkreditasiya. Beynəlxalq aparıcı orqanlar Beynəlxalq Psixoanalitik Assosiasiya (IPA), Avropa Davranış və Koqnitiv Terapiyalar Assosiasiyası (EABCT), Dialektik Davranış Terapiyası üzrə Sertifikatlaşdırma Şurası (DBT-LBC), EMDR Europe sərt akkreditasiya tələbləri müəyyən etmişdir. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi — pasiyentin keyfiyyətli yardım almasının mühüm şərtidir. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində psixoterapevtik fəaliyyət xüsusi tənzimlənmir; beynəlxalq aparıcı orqanların heç birində akkreditə edilmiş milli assosiasiya mövcud deyil; beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmiş yeganə peşə təşkilatı — Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasıdır (AZPA).

Bu üç xəttin kəsişdiyi nöqtədə bir nəticə görünür: Azərbaycanda Azərbaycan dilində standartlaşdırılmış, sübuta əsaslanan, beynəlxalq müasir təlimatlara əsaslanan klinik psixiatriya və psixoterapiya istinad kitabına ehtiyac mövcuddur.

Niyə məhz indi?

Üç səbəb bu kitabın indi yazılmasını məntiqli addım edir:

1. ÜST-ün XBT-11-ə keçidi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının XBT-11 təsnifatı 2022-ci ildə qüvvəyə minmişdir və 2026-cı ildən etibarən beynəlxalq səhiyyə statistikasında məcburi standart olur. Bu təsnifat psixi pozuntular fəslini əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qurmuşdur: yeni nozologiyalar əlavə edilmişdir (kompleks PTSP, uzanmış kədər pozuntusu, qumar pozuntusu və oyun pozuntusu, kompulsiv cinsi davranış pozuntusu, oyenma pozuntusu və başqaları), bəzi köhnə kateqoriyalar yenidən təsnif edilmişdir, bütün təsnifat sistemində daha çox ölçülülük (dimensiyal yanaşma) tətbiq olunmuşdur. Azərbaycan dilində bu yenilənmələri əhatə edən sistemli istinad mənbəyi indiyə qədər mövcud olmamışdır.

2. Pandemiya sonrası başlanğıc səviyyənin dəyişməsi. COVID-19 pandemiyası psixi sağlamlıqda «yeni başlanğıc səviyyəsi» adlandırılan fenomeni yaratmışdır: depressiya və təşviş səviyyəsi əvvəlki normaya qayıtmamışdır, qalıcı olaraq yüksək səviyyədə qalmışdır. Bu, klinik praktikada artmış yük deməkdir. Mütəxəssislərin aktiv hazırlığı və standartlaşdırılmış istinad mənbələrinin əlçatımlığı — sistemin bu yükü daşıya bilməsi üçün zəruri şərtdir.

3. Yerli mütəxəssis bazasının böyüməsi. Azərbaycanda son 10–15 ildə psixologiya, psixiatriya və psixoterapiya sahələrində mütəxəssislərin sayı sürətlə artmışdır. Universitetlər psixologiya proqramları açır, gənc mütəxəssislər xaricdə (Türkiyə, Almaniya, Rusiya, ABŞ) əlavə təhsil alır, özəl klinik mərkəzlər çoxalır. Lakin bu mütəxəssis bazası azərbaycan dilində istinad ədəbiyyatından məhrum qalmışdır. Mövcud azərbaycandilli ədəbiyyat ya köhnəlmişdir (sovet dövrü tərcümələri, XBT-10-a əsaslanan), ya parçalanmışdır (yalnız ayrı-ayrı pozuntular üzrə), ya da populyar səviyyədədir (peşəkar klinik istifadə üçün yetərli deyil).

Niyə məhz Azərbaycanda?

Azərbaycanın özünəməxsus klinik konteksti bu kitabın əhəmiyyətini artırır.

Azərbaycan dili — peşə dili kimi. Klinik psixiatriya və psixoterapiya peşə dili — universitet auditoriyalarında, tədris ədəbiyyatında, klinik praktikada — formalaşma prosesidir. Hər nozologiyanın dəqiq adlandırılması, hər diaqnostik meyarın aydın ifadə edilməsi, hər müdaxilə protokolunun standartlaşdırılması — bu kollektiv prosesdir. Bu kitab bu prosesə töhfə verir: ÜST — ICD-11 və DSM-5-in azərbaycan dilində standartlaşdırılmış formada təqdimatı, beynəlxalq təlimatlardakı terminlərin azərbaycan klinik sahəsinə uyğunlaşdırılması, yerli peşəkar ədəbiyyatda istifadə olunan terminlərin (səhiyyə.gov.az, isim.az, Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının protokolları) əsas götürülməsi. Bu kitabın terminologiyası rəsmi Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və AZPA mənbələri ilə razılaşdırılmışdır.

Türk dünyası ilə peşəkar əlaqələr. Türkiyə Azərbaycanın yaxın qonşusudur — bu, Avropa Davranış və Koqnitiv Terapiyalar Assosiasiyası (EABCT) çərçivəsində iki akkreditə edilmiş koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) assosiasiyasına (TACBT və ACBP), dialektik davranış terapiyası (DBT) və göz hərəkətləri ilə desensitizasiya və yenidən emal (EMDR) təlimi üzrə geniş infrastruktura malik olan ölkədir. Azərbaycan və türk dillərinin yaxınlığı azərbaycanlı mütəxəssislərə türk təlim sistemindən ən geniş şəkildə istifadə imkanı verir. Bu kitabın Azərbaycan klinik terminologiyası türk peşə ədəbiyyatı ilə terminoloji ardıcıllıq saxlayır — bu, mütəxəssisin türkdilli təlim materiallarına keçidini asanlaşdırır.

Regional kontekst. Azərbaycan post-sovet məkanında yerləşir; klinik praktikada hələ də sovet dövrü psixiatrik terminologiyası və yanaşmaları qismən qorunub saxlanılır. Eyni zamanda, ölkə Avropa Şurasının üzvüdür və beynəlxalq səhiyyə standartlarına inteqrasiya yolundadır. Bu kitab keçid dövründə klinik praktika üçün müasir beynəlxalq standartlarla yerli klinik reallıq arasında körpü rolunu oynayır.

Klinik müəllif təcrübəsi. Bu kitab yalnız beynəlxalq mənbələrin tərcüməsi və ya tərtibi deyil. O, müəllifin 20 ildən çox klinik praktikası, müşahidələri və işlənmiş protokolları ilə zənginləşdirilmişdir. Kitabın müvafiq bölmələrində təqdim olunan iki müəllif klinik protokolu — uşaq enurezi üçün modifikasiya edilmiş alarm terapiyası və psixogen depressiyanın iki mərhələli müalicə strategiyası — Azərbaycan klinik kontekstində uzun illər ərzində sınaqdan keçirilmiş və əldə edilmiş ölçülə bilən nəticələrlə təsdiqlənmişdir. Bu, kitabı sadəcə istinad mənbəyi olmaqdan kənara çıxarır və klinik təcrübə kitabı statusu qazandırır.

Bu kitabın hədəf auditoriyası

Bu kitab dörd əsas oxucu kateqoriyası üçün yazılmışdır:

1. Praktik klinik psixiatrlar. Diaqnostik dəqiqlik üçün ÜST — ICD-11 və DSM-5 meyarlarının yenilənmiş təqdimatı (Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı), hər nozologiya üçün psixoterapevtik strategiya xəritəsi, müəllif klinik protokolları.

2. Klinik psixoloqlar və psixoterapevtlər. Sübuta əsaslanan müdaxilə xəritəsi (sübuta əsaslanan müdaxilələr xəritəsi — müvafiq cədvəl), müəllif protokollarının metodologiyası, klinik psixoterapiyanın təşkilati çərçivəsi.

3. Tibb və psixologiya tələbələri. Sistemli, müasir, beynəlxalq standartlara uyğun istinad ədəbiyyatı, bu ədəbiyyat Azərbaycan dilində indiyədək mövcud olmamışdır.

4. Səhiyyə sisteminin idarəçilik səviyyəsində iştirak edənlər və qərar qəbul edənlər. Standartlaşdırılmış protokollar keyfiyyət nəzarəti, mütəxəssis hazırlığı və xidmətlərin optimallaşdırılması üçün əsas yaradır.

Yekun

Müasir psixiatriya və psixoterapiya — tibbin sürətlə inkişaf edən, sübut əsası daim genişlənən, beynəlxalq standartları mütəmadi yenilənən sahəsidir. Azərbaycanda bu sahənin inkişafı qarşıda duran ən vacib səhiyyə vəzifələrindən biridir.

Bu kitab — bu inkişafa töhfə vermək məqsədi daşıyır. O, hazır cavablar verməyə deyil, sistematik klinik təfəkkür üçün etibarlı çərçivə təqdim etməyə yönəlmişdir. Hər mütəxəssis öz klinik təcrübəsində bu çərçivəni özünəməxsus formada doldurur — pasiyentlərlə işləyərək, beynəlxalq akkreditasiya proqramlarında iştirak edərək, peşəkar inkişaf prosesində.

Pasiyentlər üçün isə bu kitab — onların aldıqları yardımın keyfiyyətini qiymətləndirmək, düzgün sualları vermək, sübuta əsaslanan müalicə tələb etmək üçün vasitə ola bilər. Sağlamlıq sahəsində, xüsusilə psixi sağlamlıqda, məlumatlı pasiyent keyfiyyətli xidmətin mühüm şərtidir.

Bu Müqəddimə bütün kitabın oxunması üçün lazımi kontekst yaradır. Növbəti fəsillərdə psixopatologiyanın əsasları, klinik müsahibə və psixiatrik müayinə, daha sonra isə ÜST-ün XBT-11 və DSM-5-TR təsnifatları üzrə hər bir əsas psixi pozuntunun sistemli təqdimatı veriləcəkdir.

Bakı, 2026

Kənan Rəhimov

Müəllif və töhfə verənlər

Müəllif: Kənan Rəhimov (Bakı, 2026)

Veb-sayt: ragimoff.org

Təşəkkürlər: Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasına (AZPA), Azərbaycan Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasına və Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinə klinik protokolların hazırlanmasında göstərdikləri əvəzsiz əməyə görə dərin minnətdarlıq bildirilir. Beynəlxalq tövsiyə hazırlayan təşkilatlara (NICE, APA, WFSBP, CANMAT, ISTSS, ÜST) sübuta əsaslanan psixiatriyanın inkişafına töhfələri üçün təşəkkür edilir.

Bakı, 2026

Təşəkkürlər

Bu kitab Azərbaycanda müasir psixiatriyanın inkişafına töhfə vermək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının KTTD komandasına, beynəlxalq klinik tövsiyələri hazırlayan mütəxəssislərə, Popov-Vid-in post-sovet psixiatrik ənənəsinə, Azərbaycan həmkarlarına — hamısına təşəkkür edilir.

Kitab ictimai müzakirəyə açıq şəkildə hazırlanmışdır və inkişaf etməyə davam edəcək. Rəylər, qeydlər və təkliflər sonrakı nəşrlərdə nəzərə alınacaq.

DÜNYADA PSİXİ SAĞLAMLIQ BÖHRANI: STATİSTİKA, MEYLLƏR VƏ MÜALİCƏ BOŞLUĞU

Qlobal mənzərə

XXI əsrin üçüncü onilliyinə XXI əsrin üçüncü onilliyində psixi sağlamlıq sahəsi tarixi miqyaslı böhranla üz-üzədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 2025-ci ildə dərc olunmuş «Mental Health Atlas 2024» hesabatına əsasən, dünyada 1 milyarddan çox insan hər hansı psixi pozuntu ilə yaşayır. Bu rəqəm planetin ümumi əhalisinin təxminən səkkizdə birinə bərabərdir və müasir tibb tarixində qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.

Psixi pozuntuların payı sadəcə xəstə insanların sayı ilə məhdudlaşmır. ÜST məlumatlarına görə, psixi pozuntular bütün dünyada xəstəliklərə görə yaşanan əlilliklə yaşanılan illərin (ing. years lived with disability, YLD) demək olar ki, altıda birini təşkil edir və ölümlə nəticələnməyən yük baxımından ürək-damar xəstəlikləri ilə müqayisə olunan əsas amildir. Yalnız depressiya və təşviş pozuntuları qlobal iqtisadiyyata məhsuldarlıq itkisi şəklində ildə təxminən 1 trilyon ABŞ dolları dəyərində ziyan vurur.

Bu rəqəmlərin arxasında konkret klinik reallıqlar dayanır. 2021-ci ildə 359 milyon insan təşviş pozuntularından (o cümlədən 72 milyon uşaq və yeniyetmə), 280 milyon insan isə depressiya pozuntularından əziyyət çəkmişdir. Bipolyar pozuntu 37 milyon, şizofreniya isə 24 milyondan çox insanı əhatə edir. Lakin bu rəqəmlər yalnız diaqnoz qoyulmuş halları əks etdirir; gerçək yayılma göstəriciləri xeyli yüksəkdir, çünki bir çox ölkədə diaqnostik infrastruktur kifayət qədər inkişaf etməmişdir.

1990–2021-ci illər tendensiyaları

Xəstəliklərin Qlobal Yükü (ing. Global Burden of Disease, GBD) tədqiqat proqramının uzunmüddətli məlumatları son 30 ildəki kəskin artımı təsdiqləyir. Aşağıdakı cədvəl əsas nozologiyalar üzrə yayılma dinamikasını göstərir.

Cədvəl 1. Əsas psixi pozuntuların qlobal yayılma dinamikası, 1990–2021

Pozuntu	1990 (mln)	2019 (mln)	2021 (mln)	Mütləq artım	Yaş-standartlaşdırılmış artım
Təşviş pozuntuları	311	458	359[1]	+47%	+12,6%
Depressiya pozuntuları	172	279	280	+63%	+9,8%
Bipolyar pozuntu	26	40	37	+42%	+1,2%
Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu (DDHP; uşaq və yeniyetmə)	71	84	84	+18%	+0,4%
Yemə pozuntuları	7	14	14	+100%	+52%
Şizofreniya	17	23	24	+41%	+0,7%
Autizm spektri pozuntusu	18	28	28	+56%	+1,8%
Cəmi (psixi pozuntular)	**654**	**970**	**1052**	**+61%**	**+8,4%**

Mənbə: Səhiyyə Ölçmələri və Qiymətləndirmə İnstitutu (ing. Institute for Health Metrics and Evaluation), «Xəstəlik Yükünün Qlobal Tədqiqi» (Global Burden of Disease Study) 2021 («Lancet Psixiatriya», 2024). 2021-ci il rəqəmlərində COVID-19 pandemiyasının düzəlişi nəzərə alınmışdır.

[1] 2021-ci ildə təşviş pozuntularının rəqəmi 2019-cu ildəki göstəriciyə nisbətən aşağı görünsə də, bu, metodoloji yenilənmə ilə bağlıdır; pandemiya dövründə həqiqi

yayılma kəskin yüksəlmiş, 2021-ci ilin metodoloji yenilənməsi isə göstəricini aşağı salmışdır.

Cədvəldən aydın görünür ki, mütləq sayda 2019-cu ilə qədər təşviş pozuntularında ən böyük artım (147 milyon əlavə hal) və depressiyada (107 milyon) qeydə alınıb. Yaş-standartlaşdırılmış göstərici (yəni əhalinin yaşlanması ilə bağlı təbii artımı çıxardıqda qalan həqiqi epidemioloji artım) yemə pozuntularında ən yüksəkdir — +52%, bu da müasir cəmiyyətdə bədən görünüşünün qavranılması, sosial şəbəkələr və qidalanma mədəniyyəti ilə əlaqəli sosial-psixoloji dəyişikliklərlə əlaqəli əsas amillərdən biridir.

COVID-19 pandemiyasının təsiri

2020–2022-ci illər ərzində qlobal psixi sağlamlıq sahəsində vəziyyət ən kəskin dövrünü yaşayırdı. «The Lancet» jurnalında 2021-ci ildə dərc olunmuş meta-analizə görə (COVID-19 Mental Disorders Collaborators, 2021), pandemiyanın birinci ilində:

- Depressiv pozuntunun (DSM-5-TR-ə görə major depressiv pozuntu, MDP) yayılması gözlənilən səviyyədən +27,6% artdı.
- Təşviş pozuntularının yayılması +25,6% artdı
- 53 milyon əlavə depressiya halı və 76 milyon əlavə təşviş halı qeydə alındı

Pandemiyanın bilavasitə təsiri zəiflədikdən sonra da rəqəmlər tam olaraq pandemiya öncəsi səviyyəsinə qayıtmadı. Tədqiqatçıların əksəriyyəti bunu «yeni əsas səviyyə» (ing. new baseline) fenomeni kimi izah edir: cəmiyyətin uzunmüddətli izolyasiyası, iqtisadi qeyri-müəyyənlik, ailədaxili münasibətlərdə yaşanan dəyişikliklər və xroniki stress səviyyəsinin yüksəlməsi qalıcı xarakter almışdır.

Yayılma və artım sürəti üzrə ən çox yayılmış pozuntular

Klinik baxımdan iki fərqli sıralama vacibdir: mütləq sayda ən geniş yayılmış pozuntular və yaş standartlaşdırılmasına görə ən sürətli artan pozuntular.

Cədvəl 2. Yayılma və artım sürəti üzrə ilk onluq (2021)

Sıra	**Yayılma üzrə (mln)**	**Artım sürəti üzrə (1990–2021, %)**
1	Təşviş pozuntuları — 359	Yemə pozuntuları — +52%

Sıra	**Yayılma üzrə (mln)**	**Artım sürəti üzrə (1990–2021, %)**
2	Depressiya — 280	Bədən dismorfik pozuntusu (BDP) — +35%
3	DDHP — 84	Autizm spektri pozuntusu — +1,8% (yaş-standartlaşdırılmış)
4	Bipolyar pozuntu — 37	Sosial təşviş pozuntusu — +18%
5	Autizm spektri pozuntusu — 28	Generalizə olunmuş təşviş — +15%
6	Şizofreniya — 24	Posttravmatik stress pozuntusu (PTSP) — +14%
7	Yemə pozuntuları — 14	Major Depressiv Pozuntu — +9,8%
8	OKP — 12	Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) — +6,5%
9	PTSP — 10	DDHP — +0,4% (yaş-standartlaşdırılmış)
10	Şəxsiyyət pozuntuları — 9	Maddə istifadəsi pozuntuları — +5,3%

Mənbə: Xəstəliklərin Qlobal Yükü tədqiqatı 2021 (ing. GBD; IHME, Seattle); ÜST-ün «Psixi sağlamlıq atlası 2024» (ing. Mental health atlas 2024) hesabatı.

[2] Autizm spektrinin artımı qismən diaqnostik meyarların genişlənməsi və erkən aşkarlanma proqramları ilə bağlıdır, lakin gerçək epidemioloji artımın da varlığı tədqiqatlarla təsdiqlənir.

Müalicə boşluğu fenomeni

Psixi sağlamlıq sahəsində ən kəskin problem yayılma rəqəmləri deyil, alınan və lazım olan müalicə arasındakı uçurumdur. Bu fenomen elmi ədəbiyyatda *müalicə boşluğu (ing. treatment gap) kimi tanınır*.

Cədvəl 3. Müalicə boşluğu — pozuntular üzrə müqayisə

Pozuntu kateqoriyası	Hər hansı müalicə alanlar	Uyğun müalicə alanlar	Müalicə boşluğu
Şizofreniya (yüksək gəlirli ölkələr)	təxminən 70%	təxminən 50%	30–50%
Şizofreniya (aşağı gəlirli ölkələr)	<11%	<5%	**89%+**
Bipolyar pozuntu	təxminən 50%	təxminən 25%	50–75%
Major Depressiv Pozuntu (qlobal)	təxminən 30%	təxminən 15%	70–85%
Təşviş pozuntuları (qlobal)	**27,6%**	**9,8%**	**72,4–90,2%**
OKP	təxminən 25%	təxminən 10%	75–90%
PTSP	təxminən 20%	<10%	80–90%

Mənbə: ÜST Atlas 2024; Alonso J. və b. Təşviş pozuntuları üzrə müalicə boşluğu qlobal xarakter daşıyır [Treatment gap for anxiety disorders is global]. «Depressiya və Təşviş» (Depression and Anxiety), 2018; 35(3): 195–208.; Thornicroft və b., «Britaniya Psixiatriya Jurnalı» (British Journal of Psychiatry), 2017.

Bu rəqəmlərin arxasında ciddi struktur fərqi durur. Psixotik pozuntular (şizofreniya, şizoaffektiv pozuntu, ağır bipolyar) — yəni cəmiyyətdə daha çox tanınan pozuntular — psixiatrik xəstəxana sistemləri, dövlət statistikası, ÜST təsnifatı ilə əhatə olunmuşdur. Bu pozuntularda diaqnostika nisbətən sistemli, müalicə nisbətən nəzarətdə, statistika nisbətən etibarlıdır.

Təşviş və depressiya pozuntuları isə tamamilə fərqli vəziyyətdədir. Bunlar «gizli» və ya «boz zona» pozuntularıdır:

- Pasiyent əksər hallarda psixiatrik xidmətə deyil, ümumi praktikaya, somatik mütəxəssislərə, neyroloqlara müraciət edir.
- Diaqnoz qoyulduqda müalicə əksər hallarda yalnız simptomatik dərman müalicəsi ilə məhdudlaşır
- Psixoterapiya ya təklif olunmur, ya da geniş yayılmış qeyri-standart metodlar şəklində — qeyri-standart, sübuta yetirilməmiş metodlarla — verilir

- Pasientin obyektiv vəziyyətinin uzunmüddətli izlənilməsi sistemli şəkildə həyata keçirilmir

Məhz bu hal qlobal psixi sağlamlıq böhranının özəyini təşkil edir. Sayca ən böyük yük məhz «boz zona» pozuntularındadır, lakin ən az nəzarətli sistem də onların ətrafında qurulmuşdur.

Psixogen aspekt: kök problem

Yuxarıda göstərilən rəqəmlərin klinik mənasının tam başa düşülməsi üçün bir əsas həqiqəti vurğulamaq lazımdır: təşviş və depressiya pozuntularının böyük əksəriyyətində psixososial faktorlar mərkəzi rol oynayır. Bu o deməkdir ki, onların ilkin səbəbi neyrobioloji disfunksiya deyil, psixoloji proseslərdir: kognitiv təhriflər, zədələnmiş bağlanma sxemləri, həll olunmamış matəm prosesləri, autoaqressiv özünüqiymətləndirmə nümunələri, əsas inanclardakı təhriflər kimi psixoloji proseslərdir, həll olunmamış matəm prosesləri, autoaqressiv özünüqiymətləndirmə nümunələri, əsas inanclardakı təhriflər.

Müasir tədqiqatlar göstərir ki, depressiv pozuntuların başlanğıcında psixososial faktorlar 60–80% hallarda mərkəzi rol oynayır. Kendler və əməkdaşlarının uzunmüddətli əkiz tədqiqatları (Virginia Twin Registry, 1990–2010-cu illər) müəyyən etmişdir ki, Major Depressiv Pozuntu epizodlarının 60%-dən çoxu müəyyən edilə bilən stressogen həyat hadisəsi ilə tətiklənir (Kendler və b., American Journal of Psychiatry, 1999, 2003). Klassik post-sovet psixiatriya məktəbinin görkəmli nümayəndəsi prof. V. D. Vid (Sankt-Peterburq, Bexterev İnstitutu) öz əsərlərində fərqli mövqe irəli sürür: somatik şikayətlərlə müraciət edən pasiyentlərin 60–70%-də əslində somatik xəstəlik aşkar edilmir — bu pasiyentlərin əsas problemi psixogen mənşəlidir, lakin yanlış diaqnostika nəticəsində somatik müalicə alırlar (Popov Yu.V., Vid V.D., *Müasir klinik psixiatriya*, 2-ci nəşr, 2006).

Bu mövqeni tarixi və müasir kontekstdə təsdiqləyən mühüm fakt — keçmiş SSRİ məkanında onilliklər boyu istifadə edilmiş «vegetativ-damar distoniyası» və «neyrosirkulyator distoniya» diaqnozlarının fenomeni. Bu diaqnozlar nevroloji və kardioloji şöbələrdə geniş şəkildə qoyulurdu, halbuki onların etioloji əsası elmi cəhətdən təsdiq edilməmişdir. Eyni pasiyentlər psixiatrik və ya psixoterapevtik müayinə zamanı somatik simptom pozuntusu (XBT-10: F45.0) və ya uyğunlaşma pozuntusu (XBT-10: F43.2; XBT-11-də bədən distressi pozuntusu — 6C20) kateqoriyalarına uyğun gəlirdilər, depressiya və ya panik pozuntu kriterlərinə cavab verirdilər. Bu sistemli yanlış diaqnostika fenomeni psixiatrik problemlərin somatik şöbələrdə tanınmaması ilə bağlıdır — və bu vəziyyət müasir klinik praktikada da müşahidə olunur.

Eyni qaydada təşviş pozuntularının böyük əksəriyyəti psixososial faktorlarla — uşaqlıq dövründəki bağlanma pozuntuları, valideynlik üslubu, psixotravmatik təcrübələr, kompleks fundamental inanışlar — bilavasitə bağlıdır. Dünya Psixiatriya Assosiasiyasının (WPA) və beynəlxalq psixoterapevtik məktəblərin aparıcı nümayəndələri (O. Kernberg, G. Gabbard, A. Beck, V. Frankl) ardıcıl olaraq vurğulayırlar ki, depressiv epizodun farmakoloji yolla kəsilməsi onun psixoloji köklərini həll etmir. Bu səbəbdən depressiya müalicəsində psixoterapevtik müdaxilə birinci xətt müalicəsidir — yüngül və orta dərəcəli hallarda yalnız psixoterapiya şəklində, ağır hallarda farmakoterapiya ilə paralel.

Bu fakt müalicə strategiyaları üçün həlledici nəticələrə malikdir. Psixogen pozuntu üçün dərman simptomatik təsir göstərir, lakin kök problemi həll etmir. Antidepresan pasiyentin əhval-ruhiyyəsini qaldıra bilər, lakin onu özünü ittiham etməyə vadar edən kognitiv struktura toxunmur. Anksiolitik təşviş hücumunu kəsə bilər, lakin pasientin dünyanı təhlükəli kimi qiymətləndirməyə yönələn fundamental inanışını dəyişdirmir. Pasient dərmanı dayandırdıqda və ya yeni stress amili ilə üzləşdikdə rastlaşdıqda — pozuntu çox vaxt bərpa olunur, hətta daha ağır formada təzahür edir.

Psixogen pozuntuların kök problemi yalnız psixoterapevtik müdaxilə vasitəsilə həll oluna bilər. Bu, psixoterapiyanın dərman müalicəsindən üstün olduğu mənasında deyil; bu, iki müdaxilənin müxtəlif məqsədlərə xidmət etməsi deməkdir:

1. Farmakoterapiya — simptomları idarə edir, akut vəziyyətləri sabitləşdirir, neyrobioloji komponentə təsir göstərir.
2. Psixoterapiya — pozuntunun psixoloji köklərini həll edir, kognitiv strukturu yenidən qurur, davranış modellərini dəyişir, residiv riskini azaldır

Bu iki müdaxilə bir-birini istisna etmir — onlar bir-birini tamamlayır. Lakin müasir səhiyyə sistemləri, xüsusilə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə demək olar ki, tamamilə farmakoterapiyaya yönəlmişdir. Psixoterapevtik xidmətlər — hətta mövcud olduqda belə — standartlaşdırılmamış, keyfiyyət nəzarəti olmayan, lisenziyalaşdırılmamış sahədədir. Bu, pasiyenti iki riskli vəziyyətdən birinə sövq edir: ya yalnız simptomatik dərman müalicəsi alır (kök problem həll olunmadan), ya da nəzarətsiz, qeyri-keyfiyyətli psixoloji yardım alır (problemin ağırlaşma riski ilə).

Yekun

Bu fəsildə təqdim olunan rəqəmlər və tendensiyalar bir nəticəyə gətirib çıxarır: dünyada hazırda 1 milyarddan çox insanı əhatə edən psixi sağlamlıq böhranı son 30 ildə kəskin artım göstərmiş və COVID-19 pandemiyasından sonra yeni əsas səviyyədə qalmışdır. Bu yükün böyük əksəriyyəti təşviş və depressiya pozuntularına

düşür — bu pozuntularda psixososial komponent üstünlük təşkil edir və kök səviyyəsində həlli yalnız psixoterapevtik müdaxilə ilə mümkündür.

Eyni zamanda, məhz bu pozuntular üzrə müalicə boşluğu ən böyükdür: təşviş pozuntuları olan hər 10 pasiyentdən yalnız 3-ü hər hansı müalicə alır, yalnız 1-i isə uyğun müalicə alır. Bu boşluğu doldurmağın yeganə yolu — keyfiyyətli, standartlaşdırılmış, sübuta əsaslanan psixoterapevtik xidmətdir.

Bu mövqedən çıxış edərək, növbəti fəsildə sübuta əsaslanan psixoterapevtik strategiyaların — onların təsnifatı, klinik tətbiq sahələri, doğruluq səviyyələri — sistematik təhlili təqdim olunur.

PSİXOPATOLOGİYAYA GİRİŞ

Bu bölmənin məqsədi

Müasir psixiatrik təsnifatlar (Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci reviziya (XBT-11); ing. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision — DSM-5-TR) əsasən operasional diaqnostik meyarlara əsaslanır: müəyyən simptomların müəyyən sayda və müddətdə olması diaqnoz qoyulması üçün şərtdir. Bu yanaşma diaqnostik etibarlılığı artırır, lakin simptomların və sindromların əsl klinik mənasını kölgədə qoya bilər.

Klassik psixiatriya — XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Karl Yaspers, Eugen Bleuler, Karl Şneyder, Kurt Şneyder, Karl Leonhard — fenomenoloji və sindromoloji yanaşma ilə inkişaf etmişdir. Bu yanaşma bu gün də klinik praktikada böyük dəyər daşıyır:

Diaqnostik meyarlar simptomları sayır, sindromologiya isə simptomların qarşılıqlı əlaqəsini və klinik təzahürlərini açıqlayır.

Sindromoloji düşüncə erkən diaqnoz üçün vacibdir — xüsusən meyarları hələ tam yığılmamış pasiyentlərdə

Niyə bu simptomların bir-biri ilə əlaqədar olduğunu anlamaq üçün patofizioloji düşüncə lazımdır — niyə bu simptomlar bir-birilə əlaqədardır, hansı funksional sistem pozulub.

Diferensial diaqnoz sindromoloji yanaşma olmadan səthidir.

Bu bölmədə psixopatoloji simptomlar əsas funksional sahələr üzrə təsnif edilir, sonra geniş yayılmış psixopatoloji sindromlar təqdim olunur.

Simptom və sindrom anlayışları

Simptom — pozuntunun tək bir təzahürü (məs. halüsinasiya, sayıqlama, depressiv əhval (vahid yazılış: halüsinasiya)).

Sindrom – bir-birilə əlaqəli simptomların ardıcıl şəkildə birləşməsi, müəyyən nozoloji vahidə xas olan və ya bir neçə nozologiyada təkrarlanan.

Nozoloji vahid – etiologiya, patogenez, klinik gediş və müalicə xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirilən xəstəlik (məs. şizofreniya, bipolyar pozuntu, alzheimer xəstəliyi).

Klinik praktikada həkim tipik olaraq simptomlardan sindroma, sindromdan diaqnoza doğru irəliləyir. Düzgün sindromoloji qiymətləndirmə pasiyentin müayinə və müalicəsinin əsasını təşkil edir.

Psixopatoloji simptomların təsnifatı

Şüur pozuntuları

Kəmiyyət pozuntuları (azalma):

Tutqunlaşma (ing. obnubilation) — şüurun yüngül azalması, reaksiyaların yavaşlaması

Somnolentlik – yuxulu vəziyyət, asanlıqla oyandırılır

Sopor — yalnız güclü qıcıqlandırıcılarla qısamüddətli oyanma ilə müşayiət olunan şüur pozuntusudur

Koma – şüurun tam itirilməsi, qıcıqlandırıcılara cavab yoxdur

Keyfiyyət pozuntuları (şüurun məzmununun dəyişməsi ilə gedən):

Delirium — kəskin başlanğıc, dalğalanan şüur, dezoryentasiya, görmə halusinasiyaları, psixomotor aqitasiya. Tipik səbəblər: alkoqol abstinensiya sindromu, infeksiya, intoksikasiya, qaraciyər və böyrək çatışmazlığıdır, infeksiya, intoksikasiya, qaraciyər/böyrək çatışmazlığı.

Onirik (yuxuya bənzər) vəziyyət – fantastik səhnələr, pasiyent özünü onların iştirakçısı kimi hiss edir

Amentiv vəziyyət – dərin dezoryentasiya, dağılmış düşüncə, nitq nizamsızlığı

Alatoranlıq şüur vəziyyəti (ing. twilight state) – şüurun «tunelvari» daralması, avtomatik davranış, sonradan amneziya. Epilepsiyada, histerik vəziyyətlərdə tipikdir.

Qavrayış pozuntuları

İllüziyalar – real obyektin yanlış qavranması (məs. divardakı kölgə insan kimi qavranır).

Halüsinasiyalar — real qıcıqlandırıcı olmadan qavrayışdır. Modallıq üzrə:

Eşitmə halusinasiyaları – Ən geniş yayılmış halüsinasiya növüdür. «Səslər» — şərh edən, müraciət edən, əmr edici xarakter daşıyır, əmredici (ing. imperative — yüksək risk). Bu halüsinasiya növü şizofreniya üçün xarakterikdir.

Görmə halusinasiyaları – üzvi pozuntular (delirium, demensiya, intoksikasiya) üçün xarakterik.

Qoxu və dad halüsinasiyaları — temporal lob epilepsiyası və şizofreniya üçün xarakterikdir.

Toxunma halüsinasiyaları – kokain, amfetamin intoksikasiyası («dəri altı həşəratlar»).

Senestopatiyalar – bədəndə qeyri-müəyyən, qəribə, ağrılı hisslər (bədənə «həşəratlar dolaşır», «boğazda boş yer var» və s.).

Psevdohalusinasiyalar (Kandinski) – pasiyent tərəfindən «daxili» kimi qavranılır («səslər başımın içində»), lakin yenə də xarici qıcıqlandırıcı olmadan baş verir.

Funksional halusinasiyalar – yalnız real qıcıqlandırıcı olduqda yaranır (su şırıltısında səs eşitmək).

Düşüncə pozuntuları

Forma (tempo və ardıcıllıq) pozuntuları:

Sürətli düşüncə (ing. mentation acceleration) — manik epizodda müşahidə olunur

Düşüncə «uçuşu» (flight of ideas) – assosiasiyalar tez-tez dəyişir, lakin əlaqə qalır

Yavaş düşüncə — depresiya və demensiyada müşahidə olunur

Düşüncə bloklanması (alm. Sperrung) – qəfil dayanma

Tangensial düşüncə — cavab sualdan yayınaraq yan mövzuya keçir

Sirkumstansial düşüncə – həddən artıq təfərrüat

Atomistik (atactic) düşüncə – qrammatik forma saxlanır, məna pozulur (şizofreniya)

Verbiqerasiya – sözlərin və ifadələrin mənasız təkrarlanması

Neologizmlər – yeni «uydurma» sözlər (şizofreniya)

Perseverasiya — eyni söz və ya fikrin təkrarı (üzvi pozuntu)

Məzmun pozuntuları:

Persekutiv sayıqlama – təqib olunma, pislik niyyəti hiss edilir

- Böyüklük sayıqlaması – özünün böyüklüyü, gücü, zənginliyi

- Münasibət sayıqlaması (delusions of reference) – mühitin hadisələri özünə aid edilir

- Təsir sayıqlaması – kənar qüvvələrin (texniki, kosmik, mistik) onun düşüncələrinə təsiri

- Hipoxondrik sayıqlama – ağır xəstəlik hissinə inanma (senestopatiyalar və s.)

- Kotar sindromu (canlı meyit sayıqlaması) – bədən üzvlərinin «yox olduğu», «öldüyü» inancı

- Qısqanclıq sayıqlaması — həyat yoldaşının xəyanətinə inam

- Sevgi (Klerambo) sayıqlaması – tanınmış şəxsin gizli sevgisinə inanma

Sayıqlama (delusion) – yanlış, sübutlara yatmayan, mədəni kontekstə uymayan inanc. Növləri:

Həddindən artıq qiymətləndirilən (dominant) fikirlər (ing. overvalued ideas) – həqiqətə yaxın, lakin həddən artıq əhəmiyyət verilən

Obsessiyalar – sarışan, eqo-distonik (özünə yad olaraq dərk edilən) fikirlər

Əhval və affekt pozuntuları

Depressiv əhval – aşağı, kədərli, ümidsiz

Manik əhval – yüksək, eyforik və ya disforik (qıcıqlı)

Disforiya – qıcıqlı, narahat əhval

Anhedoniya – həzz alma qabiliyyətinin itirilməsi (əsas depressiv simptom)

Apatiya – emosional əskiklik, maraq itməsi

Affektiv labillik — emosiyaların tez-tez dəyişməsi

Affekt yastılığı (ing. flat affect) – emosional ifadənin zəifləməsi (şizofreniyada xarakterik neqativ simptom)

Affekt qeyri-adekvatlığı – emosional cavab vəziyyətə uyğun deyil (məs. yaxınının ölümünü gülüşlə qarşılayır)

Aleksitimiya – emosional vəziyyətini sözlə ifadə edə bilməməsi

Təşviş – qarşıdakı təhlükə hissi, daha çox somatik və vegetativ simptomlarla müşayiət olunur

Qorxu — konkret, real təhlükəyə qarşı emosional reaksiya

Panik – kəskin, tutmaşəkilli təşviş

Davranış və hərəki pozuntular

Psixomotor aqitasiya – həyəcanlı, məqsədsiz hərəkətlər

Psixomotor ləngləmə – hərəkətlərin yavaşlaması, başlatma çətinliyi

Stupor — hərəki ləngimə, mutizm və ətrafa reaksiyasızlıqla xarakterizə olunan vəziyyət, ətrafa reaksiyasızlıq

Katalepsiya — bədən duruşunun passiv saxlanması

Mum elastikliyi – ətrafın yumşaq müqavimətlə əyilməsi və saxlanması

Neqativizm – tələblərə əks hərəkət etmə

Exolaliya, exopraksiya – başqasının nitqi/hərəkətlərinin təkrarlanması

Stereotipiyalar – təkrarlanan, məqsədsiz hərəkətlər

Manerizm – adi hərəkətlərin qəribə icrası

Tiklər – qeyri-iradi əzələ yığılmaları

Kompulsiv davranış – obsessiyaları azaltmaq üçün təkrarlanan davranış (əllərin yuyulması, yoxlanması)

Yaddaş pozuntuları

Anteroqrad amneziya — hadisədən sonra baş verən hadisələrin yaddaşda qalmaması

Retroqrad amneziya – hadisədən əvvəlki dövrün yaddaşda qalmaması

Konqrad amneziya – hadisənin özünün yaddaşda olmaması

Korsakov sindromu – ağır anteroqrad amneziya, konfabulyasiyalar və dezoryentasiya. Səbəbləri: tiamin çatışmazlığı və xroniki alkoqolizmdir.

Konfabulyasiyalar – yaddaş boşluqlarını uydurmalarla doldurma

Hipermneziya – yaddaşın patoloji güclənməsi (bəzi epileptik vəziyyətlərdə)

Hipomneziya – yaddaşın azalması (depressiya, demensiya başlanğıcı)

Diqqət pozuntuları

Hipoprosexsiya – diqqətin azalması

Hiperprosexsiya – diqqətin patoloji yüksəlməsi (mania)

Diqqətin asanlıqla yayınması (DDHP, maniya)

Diqqətin yapışıqlığı – bir mövzudan ayrıla bilməmək (üzvi pozuntular)

İdrak (koqnitiv) pozuntular

Yüngül koqnitiv pozuntu – yaşa uyğun normal hədləri aşan, lakin demensiyaya çatmayan

Demensiya – idrakın geniş və davamlı azalması (yaddaş, dil, icraedici funksiyalar, vizual-məkan idrakı)

Aqnoziya – obyektləri tanıya bilməmə (görmə, eşitmə, toxunma aqnoziyaları)

Apraksiya – əvvəllər mənimsənilmiş hərəkətləri icra edə bilməmək

Afaziya – nitqin pozulması

Akalkuliya – hesablama qabiliyyətinin pozulması

İradə və motivasiya pozuntuları

Apatiya – maraqsızlıq, motivasiyasızlıq

Abuliya – iradə zəifliyi, qərar qəbul edə bilməmək

Avolisiya (ing. avolition) — məqsədli davranış üçün motivasiyanın yoxluğu

Ambivalentlik – eyni anda iki ziddiyyətli istəyin olması

Hipobuliya – iradi fəallığın azalması

Hiperbuliya – patoloji artmış iradi fəallıq

Şəxsiyyət və «Mən» pozuntuları

Depersonalizasiya — özünə yadlaşma, «Mən deyiləm» hissi

Dereallaşma – mühitin «uydurma», «gerçək olmayan» kimi qavranması

«Mən» sərhədlərinin pozulması — başqalarının düşüncələri və hissləri ilə qarışması

Düşüncələrin oğurlanması/qoyulması – başqaları «mənim düşüncələrimi oxuyur» və ya «yad düşüncələr başıma qoyulur» hissi (şizofreniyanın 1-ci dərəcəli simptomu, K. Şnayder)

Əsas psixopatoloji sindromlar

Affektiv sindromlar

Depressiv sindrom (depressiv triada):

Aşağı əhval

Psixomotor ləngləmə

Düşüncə yavaşlaması (ideator ləngimə (düşüncə ləngiməsi))

Əlavə simptomlar: anhedoniya, yuxu pozuntusu, iştahanın dəyişməsi, günah, ümidsizlik, intihara meyilli idealar

Manik sindrom (manik triada):

Yüksək əhval

Psixomotor aqitasiya

Sürətli düşüncə («ideya uçuşu»)

Əlavə simptomlar: yuxu ehtiyacının azalması, qrandioz idealar, diqqətin yayınması, riskli davranış

Qarışıq affektiv sindrom — manik və depressiv simptomların eyni vaxtda olması (məsələn, yüksək aktivlik və dərin kədər). və depressiv simptomların eyni vaxtda olması (məs. yüksək aktivlik + dərin kədər).

Təşviş sindromları

Generalizə olunmuş narahatlıq pozuntusu – davamlı, geniş təşviş, əzələ gərginliyi, autonom simptomlar.

Panik sindrom – tutma xarakterli, kəskin təşviş, ölüm qorxusu, autonom simptomlar (taxikardiya, nəfəs darlığı, tər), 10–30 dəqiqə davam edir.

Fobik sindrom – konkret obyektə/vəziyyətə qarşı qorxu, qaçınma davranışı.

Obsessiv-kompulsiv sindrom

Obsessiyalar (vəsvasəli fikirlər) (obsessiyalar) + onları azaltmaq üçün təkrarlanan davranışlar (kompulsiyalar). Pasiyent bunların absurd olduğunu dərk edir, lakin müqavimət göstərə bilmir.

Psixotik sindromlar

Paranoid sindrom – sayıqlama (təqib, münasibət, böyüklük) + Təşviş. Halusinasiyalar tipik deyil və ya minimal.

Paranoid sindrom – sayıqlama (təqib daha tipik) + halusinasiyalar (xüsusilə eşitmə) + təşviş.

Parafrenik sindrom – qrandioz fantastik sayıqlama + halusinasiyalar + affekt yüksəkliyi.

Halusinator sindrom (halusinoz) – əsasən halusinasiyalar (eşitmə və ya görmə), sayıqlama olmadan və ya minimal.

Kandinski-Klerambo sindromu (psixi avtomatizm sindromu):

Şizofreniya üçün xarakterikdir.

İdeator avtomatizm – «düşüncələrin oğurlanması», «düşüncələrin başına qoyulması»

Sensor avtomatizm – psevdohalusinasiyalar

Motor avtomatizm – «məcburi hərəkətlər»

Katatonik sindrom – stupor və ya aqitasiya, mum çevikliyi, neqativizm, mutizm, exolaliya, ekopraksiya. Diaqnostika və müalicəsi həyati əhəmiyyət daşıyır (bax. Bölmə 3).

Disforik sindrom – qıcıqlı, qəzəbli əhval, aqressiya. Epilepsiya, üzvi beyin xəstəlikləri və abstinensiya zamanı müşahidə olunur.

Eksogen-üzvi tip sindromlar (K. Bonhoeffer)

Beynin ekzogen zədələnməsinə xas olan sindromlar:

Delirium sindromu — kəskin, dalğalanan şüur səviyyəsi, dezoryentasiya, görmə halusinasiyaları, psixomotor aqitasiya. Etiologiyası: alkoqol abstinensiyası (ing. delirium tremens), infeksiyalar, intoksikasiyalar, qaraciyər/böyrək çatışmazlığıdır. (ing. delirium tremens), infeksiyalar, intoksikasiyalar, qaraciyər/böyrək çatışmazlığı.

Amentiv sindrom – dərin dezoryentasiya, qarışıq düşüncə, dağılmış affekt, fraqmentar halusinasiyalar. Ağır somatik xəstəliklərdə.

Alatoranlıq (ing. twilight) şüur vəziyyəti – şüurun tunelşəkilli daralması, avtomatik davranış, sonradan amneziya. Epilepsiya və histerik mənşəli vəziyyətlərdə müşahidə olunur.

Korsakov sindromu – fiksasiya amneziyası + konfabulyasiyalar + dezoryentasiya. Tiamin çatışmazlığı (Vernike–Korsakov sindromu), xroniki alkoqolizm.

Astenik sindrom – yorğunluq, qıcıqlanma, yaddaş və diqqət azalması, baş ağrısı, yuxu pozuntusu. Geniş yayılmış, həm üzvi, həm psixogen mənşəli ola bilər.

Demensiya sindromları

Kortikal demensiya (Alzheimer tipli) – yaddaş, dil (afaziya), praksis (apraksiya), qnozis (aqnoziya) üzrə pozuntular.

Subkortikal demensiya (Parkinson, Hantinqton) – yavaşlama, icra funksiyalarının pozulması, depresiya, lakin korteksal funksiyalar erkən mərhələdə nisbətən saxlanılır.

Frontotemporal demensiya – şəxsiyyət dəyişikliyi, dezinfibisiya (inhibisiyanın zəifləməsi), sosial uyğunsuzluq + dil pozuntuları (semantik və ya progressiv qeyri-flüenli afaziya).

Levi cisimcikləri demensiyası – flüktuasiyalı koqnitiv pozuntu, görmə halusinasiyaları, parkinsonizm və REM yuxu davranış pozuntusu ilə xarakterizə olunur.

Şəxsiyyət dəyişikliyi sindromları

Üzvi şəxsiyyət dəyişikliyi (frontal lob zədəsindən sonra və s.) – dezinhibə, sosial qaydaların pozulması, emosional labillik, plansızlıq.

Postensefalitik sindromlar – ensefalit sonrası davranış, yaddaş, affekt pozuntuları.

Beyin silkələnməsindən sonrakı sindrom – baş travmadan sonra: baş ağrısı, başgicəllənmə, yorğunluq, qıcıqlanma, konsentrasiya pozuntusu.

KLİNİK MÜSAHİBƏ VƏ PSİXİ STATUSUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Klinik müsahibənin məqsədləri

Psixiatrik klinik müsahibə üçqat məqsədə xidmət edir:

Diaqnostik – məlumat toplamaq, simptomları müəyyən etmək, diaqnoz qoymaq

Terapevtik — terapevtik münasibət (ing. rapport) qurmaq, pasiyentə dəstək göstərmək, mexanizmləri (psixoterapevtik) hərəkətə gətirmək

Qiymətləndirici – risk qiymətləndirməsi (İntihar (suisid), başqalarına zərər), funksional səviyyə, psixososial mühit

İlk müsahibə adətən 45–90 dəqiqə davam edir. Təcili vəziyyətlərdə daha qısa olur, lakin əsas məqamlar (risk, qərar) yenə də əhatə olunmalıdır.

Klinik müsahibənin strukturu

Hazırlıq

Sənədlərlə tanışlıq (göndərmə, əvvəlki tibbi qeydlər)

Otaq: sakit, qapalı, təhlükəsiz (təcili çağırış düyməsi əgər mümkündürsə)

Vaxt: kifayət qədər ehtiyat vaxt ayrılmalıdır

Tövsiyə: xəstəni tək görüş; əgər tələb olunarsa müşayiətçi (məcburi stasionara yerləşdirmə şübhəsində – (bax. Bölmə «Hüquqi-etik aspektlər»))

Açılış

Salam, özünüzü təqdim edin, məqsədi izah edin:

> «Salam, mən doktor [ad], psixiatram. Bu görüşün məqsədi sizin halınızı anlamaq və sizə kömək etmək yolunu birgə müəyyən etməkdir. Müsahibəmiz təxminən 45 dəqiqə çəkə bilər.»

Məxfilik haqqında məlumat:

> «Söhbətimiz məxfidir. …» Lakin sizə və ya başqasına ciddi təhlükə olan halda, bu məlumatı uyğun şəxslərə ötürmək məcburiyyətində qalıram – bu hüquqi tələbdir. Əgər lazım olarsa, bunu sizinlə birlikdə müzakirə edəcəyik.

Açıq sual:

> «Sizi narahat edən nədir? Buraya nə üçün gəldiyinizi mənə söyləyə bilərsiniz mi?»

Şikayətlər və hazırkı xəstəliyin tarixçəsi

Şikayətlər – pasiyentin öz sözləri ilə (mümkün olduqda sitat)

Başlanğıc – nə vaxt, hansı şəraitdə başladı?

Gediş – simptomların dəyişməsi (yüngülləşmə, ağırlaşma, dalğalı)

Tətikləyici amillər – stresslər, itkilər, dərmanlar, maddələr

Funksional təsir – işə, münasibətlərə və gündəlik fəaliyyətə təsiri

Əvvəlki müalicə cəhdləri – hansı dərmanları qəbul etdiyi və onların nə dərəcədə effektiv olduğu

Psixiatrik tarixçə

Əvvəlki diaqnozlar

Əvvəlki stasionara yerləşdirmələr (vaxt, müəssisə, müddət)

Əvvəlki dərmanlar (effektivlik, yan təsirlər)

Əvvəlki psixoterapiya

İntihar cəhdləri tarixçəsi (nə vaxt, hansı vasitə, niyyətin ciddiliyi)

Tibbi tarixçə

Xronik xəstəliklər

Cərrahi müdaxilələr

Kraniyo-serebral travmalar (şüur itkisi ilə)

Epileptik tutmalar

Endokrin pozuntular (xüsusilə tiroid vəzisinin xəstəlikləri)

Hazırda qəbul edilən dərmanlar (psixotrop yan təsirlər)

Allergiyalar

Maddə istifadəsi tarixçəsi

Alkoqol – tezlik, miqdar, abstinensiya simptomları

Tütün – siqaret, gündəlik miqdar, başlanma yaşı

Reseptli/reseptsiz dərmanlar (xüsusən benzodiazepinlər, opioidlər)

Qadağan olunmuş maddələr (kannabis, opioidlər, stimulyantlar, halusinogenlər)

Davranış asılılıqları (qumar, oyun, internet, alış-veriş)

Ailə tarixçəsi

Birinci və ikinci dərəcəli qohumlarda psixi pozuntular
İntiharlar
Maddə istifadəsi
Xronik xəstəliklər (genetik komponent ehtimal)

Şəxsi və sosial tarixçə

Doğum və erkən inkişaf
Uşaqlıq mühiti, ailə dinamikası
Travmatik təcrübələr (zorakılıq, zorakılığa məruz qalma, itki)
Təhsil
İş tarixçəsi
Münasibət tarixçəsi, ailə vəziyyəti, uşaqlar
Sosial dəstək sistemi
Hüquqi tarixçə (cinayət təqibi, məhkumluq)
Hərbi xidmət (xüsusən döyüş təcrübəsi varsa)
Cinsi və reproduktiv tarix

Xəstəlikdən əvvəlki şəxsiyyət (ing. premorbid)

Xarakter xüsusiyyətləri xəstəlikdən əvvəl
Münasibət qurma tərzi
Stressə reaksiya, davranış

Psixi statusun qiymətləndirilməsi

Psixi statusun müayinəsi (ing. Mental Status Examination, MSE) — psixiatriyanın əsas klinik aləti. Müsahibə zamanı görülən və eşidilənlərin sistematik qeydiyyatı.

Standart psixi status strukturu

1. Görünüş və davranış (ing. appearance and behaviour)

Yaşı, görünüşü
Geyim, gigiyena, baxım
Mimika, jest, davranış
Müsahibəyə münasibət (əməkdaşlıq, müqavimət, aqressivlik)
Göz təması

Psixomotor aktivlik

2. Nitq (speech)

Sürət (sürətli, normal, yavaş)

Həcm (səs gücü)

Kəmiyyət (çox, az, mutizm)

Aydınlığı, məntiqliyi

3. Əhval və affekt (ing. mood and affect)

Əhval – pasiyentin söylədiyi davamlı emosional vəziyyət («özünüzü necə hiss edirsiniz?»)

Affekt – müsahibə zamanı görünən emosional ifadə

Affekt diapazonu (geniş, daralmış, yastı)

Affektin əhval və mövzuya uyğunluğu

4. Düşüncə (ing. thought)

Forma — tempo, ardıcıllıq, bloklanma, tangensiallik, sirkumstansiallik

Məzmun – sayıqlama, obsessiyalar, fobiyalar, intihara meyilli/homisidal idealar

5. Qavrayış (perception)

Halusinasiyalar (modallıq, məzmun)

İllüziyalar

Depersonalizasiya, dereallaşma

6. İdrak (ing. cognition)

Şüurun aydınlığı

Oriyentasiya (vaxt, məkan, şəxsiyyət)

Diqqət, konsentrasiya

Yaddaş (dərhal, qısamüddətli, uzunmüddətli)

Mücərrəd düşüncə (atalar sözünün izahı, oxşarlıq)

İcra funksiyaları

Hesab

Ümumi məlumat səviyyəsi

7. İçəribaxış və mühakimə (ing. insight and judgement)

İçəribaxış (ing. insight) – pasiyentin xəstəliyini dərk etməsi (var? yox? qismən?)

Mühakimə (ing. judgement) — qərar qəbul etmə qabiliyyəti (məs., «yanan binadan necə çıxarsınız?»)

8. Risk qiymətləndirməsi

İntihar riski aşağıda ayrıca qiymətləndirilir.

Heteroaqressiv risk — başqalarına zərər niyyəti

Özünə qulluq səviyyəsi – tək yaşaya bilmə qabiliyyəti

Psixi status protokol nümunəsi

PSİXİ STATUS

Görünüş və davranış: 32 yaşlı kişi, yaşına uyğun, gigiyena saxlanılır. Geyim mövsümə uyğundur. Müsahibəyə əməkdaşlıq edir, lakin ilkin həyəcanlı görünür. Göz təması azalmışdır. Hərəki aktivlik bir qədər yüksəlmişdir.

Nitq: sürət bir qədər yüksəkdir, səs həcmi normaldır, miqdar artmışdır. Aydındır, lakin bəzən mövzudan yayınır.

Əhval: «Özümü narahat hiss edirəm … son iki həftədir yuxuya gedə bilmirəm» (sitat).

Affekt: diapazon daralmışdır, narahatlıq fonunda mövzuya uyğundur. Bəzən disforik komponentlər müşahidə olunur.

Düşüncə forması: Bəzən tangensial, lakin əsas məzmuna qayıdır. Bloklanma yoxdur.

Düşüncə məzmunu: İşi və maliyyə vəziyyətinə dair davamlı narahatlıq. dair. Sayıqlama yoxdur. intihara meyilli idea yoxdur. Hetero-aqressiv idea yoxdur.

Qavrayış: Halusinasiyalar inkar olunur. Depersonalizasiya, dereallaşma yoxdur.

İdrak: Şüur aydındır. Vaxt, məkan, şəxsiyyət üzrə düzgün oriyentasiya olunmuşdur. Diqqət konsentrasiyasında orta dərəcədə çətinlik («dünyanı tərsinə söyləmək» tapşırığında 2 səhv). Yaddaş klinik olaraq zərərsizdir. Mücərrəd düşüncə saxlanılır.

İçəribaxış: Var – simptomlarını xəstəlik kimi qəbul edir, müalicəyə motivasiyalıdır.

Mühakimə: Saxlanılır.

Risk qiymətləndirməsi: İntihar riski aşağıdır (intihara meyilli idea yoxdur, plan yoxdur, əvvəlki cəhd yoxdur, dəstək sistemi var). Heteroaqressiv risk yoxdur. Özünə qulluq səviyyəsi tamdır.

İntihar riskinin qiymətləndirilməsi

Hər psixiatrik müsahibədə mütləq edilməlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, «İntihar haqqında soruşmaq onu təhrik etmir» — əksinə, soruşmamaq isə bunu mümkünsüz edir.

Açıq, lakin pillələrlə soruşmaq

«Bu fikirlər nə qədər tez-tez gəlir?»

- «Necə etmək haqqında düşünürsünüz mü?» (plan)
- «Vasitələr əlinizdədir?» (vasitə əlçatanlığı)
- «Bunu nə vaxtsa cəhd etmisiniz mi?» (əvvəlki cəhdlər)
- «Sizi indi saxlayan nədir?» (qoruyucu amillər)

«Bəzən özünüzü çox pis hiss edirsiniz mi? Həyatın mənası olmadığını düşünürsünüz mü? düşünürsünüzmü?» (passiv intihara meyilli idea)

«Özünüzə zərər vermək və ya öldürmək haqqında düşünürsünüz mü?» (aktiv intihara meyilli idea)

Müsbət cavabda:

İntihar riski amilləri

Statik (dəyişməyən):

Əvvəlki intihar cəhdi (ən güclü proqnozlaşdırıcı amil – həyat boyu intihar riskini təxminən 30–40 dəfə artırır (mənbə: NICE, özünə qəsd riskinin qiymətləndirilməsi))

Ailədə intihar tarixi

Cins (kişi – tamamlanmış intihar, qadın – cəhd)

Yaş (yaşlı kişilər ən yüksək risk; yeniyetmələr ikinci yüksəliş dövrü)

Hüquqi tarix

Travmatik uşaqlıq

Dinamik (dəyişən):

Aktiv intihara meyilli idea, plan, niyyət

Vasitə əlçatanlığı (silah, zəhər)

Yaxın itki (tərəf, iş, sağlamlıq)

İzolyasiya

Ümidsizlik (Bek ümidsizlik şkalası ilə ölçülə bilər)

Aktif psixiatrik pozuntu (depresiya, psixoz, sərhəd şəxsiyyət pozuntusu (ŞPP), maddə istifadəsi)

Aktiv intoksikasiya

Yuxu pozuntusu (xronik)

Təcrid

Qoruyucu amillər:

Sosial dəstək

Ailə öhdəlikləri (uşaqlar)

Dini, mənəvi inanc

Müalicə əlaqəsi

Gələcək planları, ümidlər

Risk dərəcələri və klinik qərarlar

Risk	**Göstəricilər**	**Qərar**
Aşağı	Passiv idea; plan yoxdur; vasitə yoxdur; qoruyucu amillər çoxdur	Ambulator izləmə, təhlükəsizlik planı
Orta	Aktiv idea, lakin plan və niyyət konkretlənməmiş	Sıx ambulator izləmə (24–72 saatda təkrar görüş), ailə cəlb edilməsi, vasitələrin uzaqlaşdırılması, böhran nömrəsi
Yüksək	Aktiv idea + plan + niyyət; vasitə əlçatandır; əvvəlki cəhd; aktiv psixoz/dərin depresiya	**Hospitallaşdırma** (könüllü və ya qeyri-könüllü razılıq yoxdursa, qeyri-könüllü stasionara yerləşdirmə)
Təcili	Aktiv hazırlıq, açıq niyyət bəyanı	**Təcili hospitallaşdırma**, polisin cəlb edilməsi mümkündür

C-SSRS şkalası

Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası (C-SSRS) (ing. Columbia Suicide Severity Rating Scale) – sübut olunmuş, beynəlxalq olaraq tövsiyə olunan alət. Şkala 6 sualdan ibarətdir və təqribən 5 dəqiqə çəkir.

Təhlükəsizlik planı (ing. safety plan)

Aşağı–orta riskdə pasiyentlə birgə hazırlanır:

Erkən xəbərdarlıq əlamətləri (məs. uyumsuzluq, izolyasiya, əhvalın aşağı düşməsi)

Daxili davranış strategiyaları (ing. coping strategies) (məs. gəzinti, musiqi, fiziki məşq)

Sosial yayındırma (kimi və harada görmək olar)

Dəstək göstərə bilən şəxslər (kim, telefon nömrəsi)

Klinik yardım nömrələri (klinika, böhran xətti)

Mühitin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi (vasitələrin uzaqlaşdırılması, məs. silah qohuma verilir)

Heteroagressiv (başqalarına zərər) riskin qiymətləndirilməsi

Müsahibədə soruşulmalıdır:

> «Başqasına zərər vermək və ya öldürmək haqqında düşünürsünüzmü?»

Müsbət cavabda:

Konkret hədəf var?

Plan var?

Vasitə əlçatandır?

Əvvəlki aqressiv davranış?

Yüksək risk göstəriciləri:

Konkret qurban + plan + vasitə

Aktiv psixotik simptomlar (xüsusilə imperativ halusinasiyalar, təqib xarakterli sayıqlama)

Antisosial şəxsiyyət pozuntusu

Aktiv intoksikasiya

Əvvəlki zorakılıq tarixi

Yüksək riskdə hospitallaşdırma və potensial qurbanın xəbərdar edilməsi (Tarasoff prinsipi — beynəlxalq standart).

HÜQUQİ-ETİK ASPEKTLƏR

Azərbaycan psixiatrik qanunvericiliyinin əsasları

Azərbaycan Respublikasında psixiatriya yardımı aşağıdakı qanunlarla tənzimlənir:

«Psixiatriya yardımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu (sonrakı dəyişikliklərlə, son redaksiya 2024-cü ilə aiddir)

«Psixoloji yardım haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

«Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının 26 iyun 1997-ci il tarixli Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (xüsusilə 28-ci maddə – azadlıq hüququ)

Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi (qeyri-könüllü hospitallaşdırma proseduru)

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi və Cinayət-Prosessual Məcəlləsi (məcburi tibbi tədbirlər)

Psixiatriya yardımının növləri

«Psixiatriya yardımı haqqında» Qanunun 5-ci maddəsinə əsasən psixiatriya yardımı üç növdə göstərilir:

Növ	Tərif	Hüquqi əsas
Könüllü	Şəxsin öz iradəsi ilə müraciət etməsi	Maddə 5.1, məlumatlandırılmış razılıq
Qeyri-könüllü	Cinayət törətməmiş ağır psixi pozuntusu olan şəxsin iradəsindən asılı olmayaraq məhkəmənin qərarı əsasında müayinə və müalicəsi	Maddə 11, Mülki-Prosessual Məcəllə (MPM)
Məcburi (tibbi xarakterli məcburi tədbirlər)	Anlaqsız vəziyyətdə cinayət törətmiş şəxslərin məhkəmənin qərarı əsasında müayinə və müalicəsi	Maddə 12, Cinayət Məcəlləsi (CM), Cinayət-Prosessual Məcəlləsi (CPM)

Könüllü psixiatriya yardımı

Məlumatlandırılmış razılıq

Qanunun 1.0.6-cı maddəsinə əsasən məlumatlandırılmış razılıq — pasiyentin və ya onun qanuni nümayəndəsinin müalicə haqqında könüllü qərar qəbul etdiyini, müalicənin məqsədləri və faydası, müalicə tədbirlərinin həcmi, müddəti və metodu, ehtimal olunan risklər, həmçinin müalicədən imtina və onun dayandırılması imkanı barədə ona təqdim edilmiş məlumatı başa düşdüyünü bildirməsidir.

Məlumatlandırılmış razılıq tələbləri:

Yazılı şəkildə (xəstəlik tarixçəsinə daxil edilir)

Dolu məlumat verilməlidir (faydalar, risklər, alternativlər, imtina hüququ)

Pasiyent dərk etməlidir (birgə gedən koqnitiv pozuntu, intoksikasiya zamanı çətinləşir)

Sərbəst – təzyiq olmadan

16 yaşından aşağı pasiyentlər üçün – qanuni nümayəndənin razılığı

Pasiyentin hüquqları (Qanunun 23-cü maddəsi)

Sağlamlıq vəziyyəti, müalicə haqqında məlumat almaq

Yaxın qohumları, ya da seçimlə digər şəxslər ilə görüş, telefon əlaqəsi

Pul və digər maddi vəsaitlərdən sərbəst istifadə etmək

Yazışma hüququ

Dini ayinlərin sərbəst icrası

Şikayət vermək (İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) daxil olmaqla)

Qeyri-könüllü hospitallaşdırma

Hüquqi əsaslar

Qanunun 11-ci maddəsi (qeyri-könüllü hospitallaşdırma əsasları):

> Psixi pozuntunun xarakteri müayinə və müalicənin yalnız ...yalnız stasionar şəraitdə həyata keçirilməsini tələb edərsə, qeyri-könüllü müalicə… aşağıdakı əsaslar olduqda təyin edilir:

>

> 11.1.1. psixi pozuntusu olan şəxsin bilavasitə özü və (və ya) ətrafdakılar üçün təhlükəli olması;

>

> 11.1.2. şəxsin özünün əsas həyati ehtiyaclarını ödəyə bilməməsi (qulluq səviyyəsində).

Sadə ifadə ilə: «təhlükə, çarəsizlik, ya da müalicə olunmadıqda vəziyyətin ağırlaşma riski» əlavə etmək: «11.1.3. psixi pozuntusu olan şəxsə zəruri psixiatriya yardımı göstərilmədikdə onun vəziyyətinin ağırlaşması».

Qeyri-könüllü hospitallaşdırma proseduru

Mərhələ 1: İlkin qiymətləndirmə

Həkim-psixiatr (təcili psixiatrik yardım qrupu, qəbul şöbəsi) pasiyenti müayinə edir və qeyri-könüllü hospitallaşdırma əsaslarını müəyyən edir.

Mərhələ 2: Stasionara yerləşdirmə (təcili)

Hospitallaşdırma faktiki olaraq həyata keçirilir. 48 saat ərzində həkim-psixiatr komissiyası (3 həkimdən az olmayan tərkibdə) qiymətləndirmə aparmalıdır.

Mərhələ 3: Komissiyanın qərarı

Komissiya qeyri-könüllü hospitallaşdırmanın davam etdirilməsinin lazım olduğu qənaətinə gəlsə, 24 saat ərzində məhkəməyə müraciət edilir.

Mərhələ 4: Məhkəmə qərarı

Məhkəmə 5 gün ərzində (Mülki-Prosessual Məcəlləyə əsasən) işə baxır. Pasiyent (sağlamlıq vəziyyəti imkan verirsə), qanuni nümayəndə, prokuror, həkim-psixiatr iştirak edir. Məhkəmə qeyri-könüllü hospitallaşdırmanın davam etdirilməsi və ya dayandırılması haqqında qərar qəbul edir.

Mərhələ 5: Dövri qiymətləndirmə

Qeyri-könüllü hospitallaşdırma müddətində pasiyent ilk altı ay müddətində ayda bir dəfədən az olmayaraq həkim-psixiatr komissiyasında baxışdan keçirilməlidir (Maddə 28.2).

Klinik göstərişlər

Mütləq qeyri-könüllü hospitallaşdırma göstərişləri:

Aktiv intihara meyilli davranış (cəhd və ya konkret plan və vasitə)

Aktiv homisidal niyyət (konkret hədəf + plan + vasitə)

Ağır psixotik dezorqanizasiya (özünə qulluq mümkün deyil)

İmperativ halusinasiyalar (zərərli niyyətli)

Ağır maniya (qulluq səviyyəsində məhdudiyyət, zərərli risklər)

Nisbi göstərişlər (klinik mühakimə):

Ağır depresiya psixotik simptomlarla

Anoreksiya nervoza ağır somatik vəziyyətdə (bədən kütləsi indeksi (BKİ) < 15)

Qarışıq affektiv epizod

Aqressiv davranış psixoz fonunda

Məcburi tibbi tədbirlər

Qanunun 12-ci maddəsi məcburi tibbi tədbirləri tənzimləyir:

Tətbiq əsası: anlaqsız vəziyyətdə cinayət törətmiş və ya cinayət törətdikdən sonra psixi pozuntuya düçar olmuş şəxslər

Yalnız məhkəmənin qərarı əsasında

Cinayət Məcəlləsinin 21-ci, 93–99-cu maddələri və Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin (CPM) 468–487-ci maddələri ilə müəyyən olunur

İxtisaslaşdırılmış psixiatriya stasionarlarında həyata keçirilir

Növləri (CPM-ə əsasən):

Ümumi tipli psixiatriya stasionarlarında məcburi müalicə

İxtisaslaşdırılmış psixiatriya stasionarlarında məcburi müalicə

İxtisaslaşdırılmış psixiatriya stasionarlarında intensiv müşahidə altında məcburi müalicə

Klinik psixoloqun hüquqi vəziyyəti

«Psixoloji yardım haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən klinik psixoloqun fəaliyyət dairəsi və səlahiyyətlərinin hədləri:

Psixoloqun fəaliyyət sahəsi

Psixoloji yardım göstərmək hüququ — psixoloji məsləhət, psixodiaqnostika, psixokorreksiya, psixoterapevtik müdaxilələr (uyğun ixtisası olduqda)

«Psixoloq», «psixoloji», «psixoanaliz», «psixodiaqnostika», «psixoterapiya» sözlərini yalnız Qanunun şərtlərinə uyğun olaraq psixoloji yardım göstərmək hüququ olan şəxslər istifadə edə bilər (3.2-ci maddə).

Psixoloqun hədləri

Psixoloqun səlahiyyətindən kənarda:

Psixiatrik diaqnoz qoymaq (yalnız həkim-psixiatr)

Dərman təyin etmək (yalnız həkim)

Qeyri-könüllü hospitallaşdırma qərarı vermək

Tibbi rəylər (məhkəmə-psixiatrik ekspertiza və s.) vermək (yalnız həkim-psixiatr)

İntihar (suisid) riski olan pasiyentlə klinik psixoloqun işi – addımlar

Pasiyent intihara meyilli idea bəyan etdikdə, klinik psixoloq aşağıdakı addımları atmalıdır:

Risk qiymətləndirməsi – Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası (C-SSRS) (ing. Columbia Suicide Severity Rating Scale) və ya klinik müsahibə (yuxarıdakı bölməyə bax)

Aşağı–orta risk: təhlükəsizlik planı tərtib edilir, sıx izləmə aparılır və pasiyent həkim-psixiatra yönəldilir, sıx izləmə və həkim-psixiatra yönəltmə

Yüksək risk – pasiyent tək buraxılmır, dərhal həkim-psixiatra və ya təcili psixiatrik xidmətə müraciət (Bakı Psixi Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət (təcili telefon: _____); təcili tibbi yardım – 103, polis – 102)

Sənədləşmə – qiymətləndirmə, qərar, atılan addımlar yazılı qeyd edilməlidir

Məxfilik məsələsi – həyat təhlükəsi olduqda məxfilik məhdudlaşdırılır (Qanunun ümumi prinsipləri)

Sənəd nümunəsi: Psixoloq tərəfindən həkim-psixiatra yönəltmə məktubu

[Klinikanın blank-ı]
Tarix: _____

Hörmətli həkim-psixiatr,

Klinik psixoloji müşayiətimdə olan pasiyent [ad, soyad, ata adı], doğum tarixi _____, [tarix] tarixində mənə müraciət etmiş və müsahibə zamanı aktiv intihara meyilli idea bəyan etmişdir.

Klinik mənzərə:
- intihara meyilli idea: [aktiv/passiv, plan var/yox, vasitə əlçatandır/yox]
- Əhval: [təsvir]
- tarixçədə intihar cəhdi: [var/yox, təfsilatları]
- Psixiatrik tarix: [əvvəlki diaqnozlar, dərmanlar]

Yuxarıda qeyd olunan əlamətlər əsasında pasiyentin təcili psixiatrik

qiymətləndirilməsinə zərurət olduğunu bildirirəm psixiatrik qiymətləndirməsinə ehtiyac olduğunu qiymətləndirirəm.

Sizdən pasiyentin müayinəsini və müvafiq qərarın verilməsini xahiş edirəm.

Hörmətlə,
[Psixoloqun ad, soyadı]
[İxtisas, sertifikat nömrəsi]
[İmza, möhür]
[Əlaqə nömrəsi]

Yetkinlik yaşına çatmamış pasiyent

15 yaşdan aşağı pasiyentlərlə işləyərkən:

Psixoloji yardım yalnız qanuni nümayəndənin razılığı ilə göstərilir

Lakin uşaq zorakılığı və ya intihara meyilli davranış aşkar edildikdə – qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda xəbər verilməlidir (Uşaqların Hüquqları haqqında Qanun, valideyn və ya müvafiq orqanlar)

Uşaq psixoterapiyasında məxfiliyin xüsusi qaydaları – əvvəlcədən razılaşdırılır

Məxfilik və onun sərhədləri

Ümumi prinsip

Pasiyent-həkim münasibətində pasiyentlə həkim arasındakı münasibət zamanı əldə edilən məlumat məxfidir. Bu, «Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında» Qanunda və «Psixiatriya yardımı haqqında» Qanunda təsbit edilmişdir.

Məxfilik pozulmasına icazə verilən hallar

Pasiyentin yazılı razılığı ilə

Hüquq-mühafizə orqanlarının yazılı sorğusu (cinayət istintaqı çərçivəsində)

Məhkəmə qərarı

Pasiyentin və ya başqalarının həyatı və sağlamlığı təhlükəsi olduqda (Tarasoff prinsipi – xəbərdarlıq və qoruma vəzifəsi)

Yetkinlik yaşına çatmamış pasiyentlər barədə məlumat valideynlərə verilir (qanun çərçivəsində)

Kollegial konsultasiya (multidissiplinar komanda daxilində)

Tarasoff prinsipi (xəbərdarlıq və qoruma vəzifəsi)

Beynəlxalq standart: əgər pasiyent konkret bir şəxsə qarşı zərər niyyətini bəyan edirsə, həkimin bu şəxsi xəbərdar etmək vəzifəsi vardır. Azərbaycan qanunvericiliyində bu birbaşa təsbit edilməsə də, ümumi prinsiplər (həyat hüququ, ictimai təhlükəsizlik) bunu nəzərdə tutur.

Yetkinlik yaşına çatmamış pasiyentlər

Yaş hədləri

15 yaşdan aşağı pasiyentlərə psixiatriya yardımı valideynin (qanuni nümayəndənin) razılığı ilə göstərilir («Psixiatriya yardımı haqqında» Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən)

15 yaşdan yuxarı: öz razılığı ilə (lakin valideynin məlumatlandırılması ümumi tövsiyə olunur)

18 yaşdan yuxarı pasiyentlər psixiatriya yardımı ilə bağlı qərarları müstəqil qəbul edir

Uşaq qoruma protokolları

Uşaq zorakılığı (cinsi, fiziki, psixoloji), laqeydlik və ya başqasına qoyulan süni pozuntu (ing. factitious disorder imposed on another, FDIA) şübhəsində həkimin xəbər vermək vəzifəsi vardır. Müraciət üçün qurumlar:

Sosial Xidmətlər Agentliyi

Uşaq Hüquqları üzrə Müvəkkil (ombudsman)

Polis (təhlükəli vəziyyətlərdə)

Aqressiv pasiyent və təhlükəsizlik tədbirləri

Hüquqi çərçivə

«Psixiatriya yardımı haqqında» Qanunun 37.4-cü maddəsi xüsusi tədbirlərdən istifadəni tənzimləyir:

> *Psixiatriya yardımı göstərən həkim-psixiatrların, digər mütəxəssislərin, orta və kiçik tibb işçilərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə onlara xüsusi tədbirlərdən (psixi pozuntusu olan şəxsin fiziki məhdudlaşdırılması, onun müvəqqəti təcrid edilməsi, xüsusi fiksasiya geyiminin tətbiq edilməsi) istifadə etmək hüququ verilir.*

Tətbiq qaydaları:

Yalnız həqiqi təhlükə olduqda

Ən az məhdudlaşdırıcı vasitə seçilməlidir

Vaxtla məhdud

Tibbi sənədlərdə qeyd aparılmalıdır

Müəssisə müdiriyyətinə məlumat verilməlidir

De-eskalasiya prinsipləri

Fiziki məhdudlaşdırmadan əvvəl:

Sakit, dostcasına yanaşma

Pasiyentin narahatlığını dinləmək

Seçim təklifi (məsələn, «Sakitləşmək üçün ayrı otaqda oturmaq və ya dərman qəbul etmək?»)

Şifahi de-eskalasiya

Yalnız bu üsullar uğursuz olduqda farmakoloji və ya fiziki məhdudlaşdırmaya keçilir

Farmakoloji məhdudlaşdırma (təcili sedasiya, TS)

İlk seçim – pasiyentin razılığı ilə oral preparatlar:

Lorazepam 1–2 mq, ağızdan

Olanzapin 5-10 mq po (ağızda dağılan tablet (ing. orally disintegrating tablet, ODT) effektivdir)

Risperidon 1–2 mq, ağızdan (lat. per os)

Razılıq və ya əməkdaşlıq olmadıqda – əzələdaxili (ing. intramuscular, i.m.):

Olanzapin im 10 mq + (lazımdırsa) lorazepam 2 mq im

Haloperidol 5 mq im + lorazepam 2 mq im (klassik kombinasiya)

Aripiprazol i.m. 9,75 mq

Diqqət: Olanzapin im + benzodiazepin parenteral – kombinasiya tənəffüs depressiyasına səbəb ola bilər. Olanzapin i.m. parenteral benzodiazepinlərlə eyni vaxtda istifadə edilməməlidir; zərurət olduqda aralarında ən azı 1 saat fasilə saxlanılır və pasiyent tənəffüs depressiyası baxımından izlənilir.

Sənəd nümunələri

Qeyri-könüllü stasionara yerləşdirməyə yönəltmə protokolu

QEYRİ-KÖNÜLLÜ HOSPİTALLAŞDIRMAYA YÖNƏLTMƏ

Tarix: _____ Saat: _____

Pasiyent haqqında məlumat:
- Ad, soyad, ata adı: _____
- Doğum tarixi: _____
- Ünvan: _____
- Şəxsiyyət vəsiqəsi/ID: _____

Müsahibə şərtləri:
- Yer: _____
- Müraciət/yönəltmə mənbəyi: _____
- Qanuni nümayəndə iştirak edib? Bəli/Xeyr; ad: _____

Klinik tablo:
[Şikayətlər, tarixçə, psixi status təsviri]

Diaqnoz (XBT-11): _____

Qeyri-könüllü hospitallaşdırma əsası («Psixiatriya yardımı haqqında» Qanunun 11-ci maddəsi):
☐ 11.1.1 Pasiyent özü və ya başqaları üçün təhlükəlidir
Qanunun 11-ci maddəsindəki bütün əsaslar (11.1.1-dən sonrakı bəndlər daxil olmaqla) rəsmi mətnə uyğun tam verilməlidir

Konkret göstəricilər:
[İntihar riski, homisidal idea, qulluq səviyyəsi və s.]

Qərar: Pasiyent qeyri-könüllü qaydada [müəssisə adı] psixiatriya stasionarına yerləşdirilir.

Sonrakı addımlar:
- 48 saat ərzində həkim-psixiatr komissiyası baxışı
- Komissiya qərarından sonra 24 saat ərzində məhkəməyə müraciət edilir

Həkim-psixiatr: _____

Sertifikat nömrəsi: _____
İmza: _____
Möhür: _____

İntihar riskinin təhlükəsizlik planı (pasiyentlə birgə)

TƏHLÜKƏSİZLİK PLANI
Pasiyent: _____ Tarix: _____

1. Erkən xəbərdarlıq əlamətləri (mənim üçün vacib siqnallar):
   - _____
   - _____
   - _____

2. Mənim daxili özünüidarə strategiyalarım (ing. coping strategies) (yalnız öz gücümlə edə bildiklərim):
   - _____
   - _____
   - _____

3. Məni yayındıracaq insanlar və yerlər:
   - _____
   - _____

4. Kömək istəyə biləcəyim insanlar (ad, telefon):
   - _____
   - _____

5. Klinik yardım (24 saat):
   - Klinikam: _____ (telefon: _____)
   - Bakı Psixi Sağlamlıq Mərkəzi (təcili): _____
   - Təcili yardım (Azərbaycan): 103
   - Polis: 102

6. Ev mühitimin təhlükəsiz hala gətirilməsi:
   - Risk yaradan vasitələr: _____
   - Onları uzaqlaşdırma planı: _____

İmzalar:

Pasiyent: _____

Həkim-psixiatr: _____

Etik prinsiplər

Beynəlxalq prinsiplər (Beynəlxalq Tibb Etikası Bəyannaməsi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST), Mədən Bəyannaməsi)

Avtonomiya – pasiyentin qərar qəbul etmə hüququ

Xeyirxahlıq (ing. beneficence) – pasiyentin xeyrinə hərəkət etmək

Zərər verməmək (ing. non-maleficence; lat. primum non nocere – ilk növbədə zərər verməmək)

Ədalət (ing. justice) – bütün pasiyentlərə bərabər münasibət

Klinik dilemmalar

Avtonomiya ilə xeyirxahlıq prinsipi arasında ziddiyyət:

Pasiyent müalicədən imtina edir, lakin onun qərar qəbul etmə qabiliyyəti şübhəlidir

Həll: Qərar qəbul etmə qabiliyyəti formal qiymətləndirilir; əgər qabiliyyət yoxsa, qanuni nümayəndə cəlb edilir; əgər qabiliyyət varsa, pasiyentin imtinası hörmətlə qarşılanır (təhlükəli olmadıqda)

Məxfilik vs. ictimai təhlükəsizlik:

Yuxarıda göstərildiyi kimi – həyata təhlükə olduqda məxfilik məhdudlaşır

Çoxsaylı rol münasibətləri (ing. multiple roles):

Pasiyent + işçi + dost rolları qarışmamalıdır

Sərt çərçivə – yalnız peşəkar münasibət

Hədiyyələr və maddi münasibətlər:

Pasiyentdən əhəmiyyətli hədiyyə qəbul etməmək

Maddi/biznes əlaqələrdən qaçınmaq

PSİXOTERAPİYANIN KLİNİK STRATEGİYALARI

Klinik psixoterapiya konsepsiyası

XX əsrin ortalarına qədər psixoterapevtik fəaliyyət əsasən məktəb ənənələri çərçivəsində qurulurdu. Psixoanalitik özünü psixoanalitik, davranış terapevti özünü davranışçı, gestalt-terapevti özünü gestalt-terapevti hesab edirdi və hər biri öz pasiyentlərini öz məktəbinin metodu ilə müalicə edirdi — pasiyentin diaqnozundan asılı olmayaraq. Bu yanaşmada terapevtin metodu pasiyentin pozuntusundan daha vacib hesab olunurdu: alət əsas, problem isə ikinci dərəcəli hesab olunurdu.

XX əsrin sonundan XXI əsrin əvvəllərinə qədər klinik düşüncədə əsaslı dəyişiklik baş verdi. Sübuta əsaslanan tibbin (ing. evidence-based medicine) prinsipləri psixoterapevtik sahəyə də tətbiq olunmağa başladı və yeni paradiqma formalaşdı. Bu paradiqmanın əsası klinik psixoterapiya konsepsiyasıdır: terapevtin əsas məktəbi nə olursa olsun, konkret pozuntu üçün sübuta əsaslanan, ən effektiv strategiyanı tətbiq etmək məsuliyyətini daşıyır.

Bu prinsipi sadə nümunə ilə izah etmək olar. Tutaq ki, terapevt psixoanalitik təhsil almışdır və 5 il fərdi analizdən keçmişdir. Onun qarşısına gecə enurezindən əziyyət çəkən 7 yaşlı uşaq gətirilir. Klassik psixoanalitik yanaşma uşağın simptomunu Edip kompleksinin, valideyn münasibətlərinin və ya uşaqlıq travmasının ifadəsi kimi izah etməyə cəhd edə bilər. Bu izahatın həqiqət dərəcəsindən asılı olmayaraq, klinik nəticə baxımından bu yanaşma effektsizdir: gecə enurezi alarm-terapiya — yəni sübuta əsaslanan davranış müdaxiləsi — vasitəsilə gecə enurezi alarm-terapiya – sübuta əsaslanan davranış müdaxiləsi – vasitəsilə 70%-dən çox halda uğurla müalicə olunur. Psixoanalitik şərhi vermək uşağın simptomunu aradan qaldırmır, müalicə müddətini uzadır, valideyn resurslarının səmərəsiz istifadəsinə səbəb olur.

Klinik psixoterapiya bu məsələdə birmənalıdır: enurez davranış protokolu ilə müalicə olunur — terapevtin «məktəbi» nə olursa olsun. Eyni qaydada panik pozuntu kognitiv-davranış terapiyası ilə, sərhəd şəxsiyyət pozuntusu DBT və ya Sxem-terapiya ilə, sadə fobiyalar ekspozisiya (məruz qalma) terapiyası ilə, travmadan sonrakı stress pozuntusu (PTSP) isə göz hərəkətləri ilə desensitizasiya və yenidən emal (ing. EMDR) və ya travma-fokuslu kognitiv-davranış terapiyası (KDT) ilə müalicə olunur. Bu seçim terapevtin şəxsi tərcihinə deyil, konkret pozuntu üzrə toplanmış elmi sübutlara əsaslanır.

Bu yanaşmanın iki praktiki əhəmiyyəti var. Birincisi, pasiyentin maraqları məktəb mənsubiyyətindən üstün tutulur: pasiyent terapevtin şəxsi peşə tarixçəsinin yox, öz pozuntusunun ən yaxşı müalicəsini almaq haqqına malikdir. İkincisi, mütəxəssisin peşə davranışında transdiaqnostik sərişdə zərurəti yaranır: terapevt yalnız bir məktəbin metodu ilə deyil, müxtəlif sübuta əsaslanan protokollarla işləməyi bacarmalıdır.

Psixoterapevtik məktəblər və mexanizmləri

Müasir klinik psixoterapiyada onlarla məktəb və metod mövcuddur. Aşağıda klinik praktika baxımından ən vacib olanların qısa təsviri verilmişdir.

Kognitiv-davranış terapiyası (ing. Cognitive Behavioral Therapy, KDT/CBT). Aaron Beck (depressiya, 1960-cı illər) və Albert Ellis (Rasional Emotiv Davranış Terapiyası — REBT) tərəfindən inkişaf etdirilən bu yanaşma kognitiv səviyyədə işləyir. Əsas postulat: hadisə özü deyil, hadisənin qiymətləndirilməsi emosional reaksiyanı müəyyən edir. Terapiyada pasiyent öz avtomatik düşüncələrini və kognitiv təhriflərini (kataastrofizasiya, ağ-qara düşüncə, fərdiləşdirmə, nəticəyə tələsmə və s.) tanımağı, yoxlamağı və daha funksional alternativlərlə əvəz etməyi öyrənir. Davranış komponenti — ekspozisiya, davranışın aktivləşdirilməsi, vərdiş təcrübələri — kognitiv dəyişiklikləri möhkəmləndirir. Ən geniş sübut toplusuna malik psixoterapevtik metoddur.

Dialektik davranış terapiyası (ing. Dialectical Behavior Therapy, DBT). Marsha Linehan tərəfindən 1980-ci illərdə xroniki intihara meyilli və sərhəd şəxsiyyət pozuntulu pasiyentlər üçün hazırlanmışdır. KDT-nin davamıdır, lakin emosional disregulyasiya, dözümlülük əskikliyi və impulsivlik problemləri olan pasiyentlər üçün xüsusi modullar əlavə edir: şüurlu diqqət (ing. mindfulness), böhranlara dözümlülük, emosiyaların idarə olunması, şəxslərarası münasibətlərdə səmərəlilik. Standart DBT həftəlik fərdi seans, qrup bacarıq öyrətmə seansları, telefonla məsləhətləşmə (ing. phone coaching) və terapevt komanda konsultasiyalarından ibarətdir.

Sxem-terapiya (ing. Schema Therapy). Jeffrey Young tərəfindən 1990-cı illərdə inkişaf etdirilən bu yanaşma KDT, gestalt, bağlanma nəzəriyyəsi (ing. attachment theory) və psixodinamik elementləri birləşdirir. Şəxsiyyət pozuntuları və xroniki, müalicəyə müqavimət göstərən depressiya/təşviş halları üçün xüsusilə effektivdir. Erkən uyğunlaşmayan sxemlərini (məsələn, «tərk edilmə», «etibarsızlıq», «qüsurlu olmaq») və onlarla əlaqəli «modları» (uşaq modu, sərt valideyn modu, sağlam yetkin modu) eyniləşdirir və yenidən yazır.

EMDR (ing. Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Francine Shapiro tərəfindən 1987-ci ildə işlənmişdir. Travmatik xatirələrin ikitərəfli stimulyasiya (ing. bilateral stimulation) (göz hərəkətləri və ya alternativ şəkildə taktil/eşitmə stimulyasiya) vasitəsilə yenidən işlənməsi üçün strukturlaşdırılmış 8-mərhələli protokoldur. PTSP üçün ÜST tərəfindən birinci sıra müdaxilə kimi tövsiyə olunur. Kompleks travma, kəskin stress reaksiyası və fobiyalar zamanı, həmçinin depressiya və təşvişin travmatik komponenti olan hallarda effektivdir, eyni zamanda depressiya və təşvişin travmatik komponenti olan hallarda effektivdir.

Şəxslərarası terapiya (ing. Interpersonal Therapy, IPT). Gerald Klerman və Myrna Weissman tərəfindən 1970-ci illərdə depressiya üçün hazırlanmışdır. Pasiyentin simptomlarını dörd şəxslərarası sahədən biri ilə əlaqələndirir: matəm, rol konfliktləri, rol keçidləri, şəxslərarası defisitlər. Strukturlaşdırılmış, qısamüddətlidir (12–16 seans) və depressiya üçün KDT-yə bərabər effektivlik göstərir.

Qəbul və öhdəlik terapiyası (ing. Acceptance and Commitment Therapy, ACT). Bu terapiya Steven Hayes tərəfindən 1980-cı illərdə inkişaf etdirilən «üçüncü dalğa» KDT yanaşmasıdır. Düşüncələrin məzmununu dəyişdirməyə deyil, onlarla münasibəti dəyişdirməyə yönəlir. Psixoloji çevikliyi (psychological flexibility) inkişaf etdirir: dəyərlərə uyğun həyat yaşamaq, ağrılı emosiyalara qarşı açıqlıq, düşüncələrdən ayrılma (ing. cognitive defusion). Xroniki ağrı, depressiya, təşviş, asılılıq pozuntuları və ekzistensial böhranlarda effektivdir.

Şüurlu fərqindəlik əsaslı kognitiv terapiya (ing. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT). Zindel Segal, Mark Williams və John Teasdale tərəfindən təkrarlanan depressiyanın profilaktikası üçün işlənmişdir. KDT-ni Con Kabat-Zinnin stressin şüurlu fərqindəlik əsaslı azaldılması (ing. Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) proqramı ilə birləşdirir. Major Depressiv Pozuntunun ən azı iki residiv epizodu olmuş pasiyentlər üçün dərman müalicəsinə bərabər və ya daha effektiv profilaktik nəticə verir.

Psixodinamik psixoterapiya klassik psixoanalizdən çıxan, lakin müasir klinik şəraitə uyğunlaşdırılmış metoddur. İstifadə olunan müxtəlif modellər var: Mentalizasiya əsaslı terapiya (ing. Mentalization-Based Therapy, MBT), Transferans əsaslı psixoterapiya (TFP — Kernberg), Qısamüddətli psixodinamik terapiya (STPP). Əsas mexanizm — pasiyentin şüursuz proseslərini, müdafiə mexanizmlərini, münasibət şablonlarını və erkən uşaqlıq təcrübələrinin bugünkü davranışa təsirini öyrənmək və yenidən yazmaqdır. Şəxsiyyət pozuntuları, xroniki depressiya və münasibət problemlərində effektivdir.

Sübut səviyyələri

Psixoterapevtik metodların effektivliyi sistematik tədqiqatlar (randomlaşdırılmış nəzarətli sınaqlar (ing. randomized controlled trials, RCT) — RCT, meta-analizlər, sistematik icmallar) əsasında qiymətləndirilir. Beynəlxalq klinik təlimatlar (NICE — Birləşmiş Krallıq, APA — Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (ing. American Psychiatric Association), WFSBP — Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası (ing. World Federation of Societies of Biological Psychiatry), ÜST) bu sübutları sintez edir və sübut səviyyələrini təyin edir:

A səviyyə (yüksək sübut) — bir-birindən müstəqil çoxlu sayda yüksək keyfiyyətli RCT-də və meta-analizlərdə təsdiqlənmiş effektivlik. Metod konkret pozuntuda birinci sıra müdaxilə hesab olunur.

B səviyyə (orta sübut) — bir neçə RCT-də təsdiqlənmiş effektivlik, lakin meta-analizlərin toplusu məhduddur və ya nəticələr arasında müəyyən uyğunsuzluqlar var. Metod ikinci sıra və ya alternativ birinci sıra müdaxilə kimi tövsiyə olunur.

C səviyyə (məhdud sübut) — yalnız ayrı-ayrı tədqiqatlarda və ya klinik hal təsvirlərində effektivlik göstərmiş metodlar. Birinci sıra metodlar effekt verməyəndə və ya əlçatan olmayanda istifadə oluna bilər.

Pozuntu üzrə müalicə strategiyalarının xəritəsi

Aşağıdakı cədvəl əsas psixi pozuntular üzrə beynəlxalq təlimatlarda tövsiyə olunan psixoterapevtik müdaxilələri sübut səviyyələri ilə birlikdə təqdim edir.

Cədvəl 4. Psixoterapevtik strategiyalar — pozuntu üzrə xəritə

Pozuntu	Birinci sıra (A)	İkinci sıra (B)	Alternativ (C)
Böyük depressiv pozuntu (XBT-11 üzrə depressiv epizod)	KDT, IPT	Sxem-terapiya, ACT, Psixodinamik	MBCT (residiv profilaktikası)
Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu (GTP)	KDT	ACT, MBCT	Psixodinamik

Pozuntu	Birinci sıra (A)	İkinci sıra (B)	Alternativ (C)
Panik pozuntu	KDT (panik-fokuslu)	Məruz qoyma terapiyası (ing. exposure therapy)	EMDR (travma komponenti varsa)
Sosial təşviş pozuntusu	KDT, qrup KDT	ACT	Psixodinamik
OKP	Obsesiv-kompulsiv pozuntu (OKP) || Məruz qoyma və cavab reaksiyasının qarşısının alınması terapiyası (ing. ERP)	KDT	EMDR OKP üçün beynəlxalq təlimatlarda tövsiyə olunmur – bu variant çıxarılmalı və yerinə təlimatlarda göstərilən alternativ müdaxilə yazılmalıdır
PTSP	EMDR, travma-fokuslu KDT (ing. Trauma-Focused CBT, TF-KDT)	Yazılı ekspozisiya terapiyası	Psixodinamik
Sərhəd şəxsiyyət pozuntusu	DBT, MBT, TFP, Sxem-terapiya	KDT	Psixodinamik
Bipolyar pozuntu (psixoterapevtik komponent)	Şəxslərarası və sosial ritm terapiyası (ing. IPSRT), KDT, ailə-fokuslu terapiya	Psixoloji məlumatlandırma	şüurlu diqqət
Yemə pozuntuları (anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza)	gücləndirilmiş KDT (ing. enhanced CBT, KDT-E), Ailə əsaslı terapiya (FBT — yeniyetmələr üçün)	DBT, IPT	Sxem-terapiya

Pozuntu	Birinci sıra (A)	İkinci sıra (B)	Alternativ (C)
Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu (ing. ADHD) – yeniyetmə və yetkin pasiyentlər	Psixoedukasiya + KDT	Davranış terapiyası	şüurlu diqqət
Uşaq enurezi	Alarm-terapiya (davranış protokolu)	Motivasiya sxemi	Psixodinamik konsultasiya (yalnız köməkçi yardım kimi)
Şəxsiyyət pozuntuları (ümumi)	Sxem-terapiya, MBT, TFP	DBT	KDT
Asılılıq pozuntuları	Motivasion müsahibə + KDT	Residiv profilaktikası, DBT	12 addımlı proqramlar
Xroniki ağrı	KDT, ACT	şüurlu diqqət	Psixodinamik

Mənbə: NICE-ın klinik təlimatları (ing. NICE Clinical Guidelines, 2022, 2024); APA-nın klinik təlimatları (ing. APA Clinical Practice Guidelines, 2019, 2024); ÜST-ün mhGAP müdaxilə təlimatı (ing. mhGAP Intervention Guide 2.0, 2016; mhGAP guideline, 2023); WFSBP-nin müalicə təlimatları (ing. WFSBP Treatment Guidelines).

Farmakoterapiya və psixoterapiya: rəqib deyil, tamamlayıcı

Psixiatrik praktikada müntəzəm yaranan sual: dərman müalicəsi, yoxsa psixoterapiya? Bu sualın özü səhvdir, çünki onlar bir-birini istisna etmir.

Düzgün sual üç ölçüdə formalaşdırılır:

1. Pozuntunun təbiəti. Ağır, neyrobioloji komponentli pozuntularda (şizofreniya, ağır bipolyar, melanxolik depressiya, ağır OKP) farmakoterapiya əsasdır, psixoterapiya tamamlayıcıdır. Psixogen, yüngül-orta ağırlıqlı, reaktiv pozuntularda (uyğunlaşma pozuntusu, generalizə olunmuş təşviş pozuntusu, sosial təşviş pozuntusu, sadə fobiyalar, uyğunlaşma pozuntuları) əsas müdaxilə psixoterapiyadır, dərman lazım gələrsə qısamüddətli köməkçi vasitə kimi istifadə olunur.

2. Pasiyentin vəziyyəti. Akut intihar (suisid) riski, ciddi funksional pozulma, qida qəbulundan imtina, psixotik elementlər varsa — farmakoterapiya akut mərhələdə üstündür. Stabilləşmədən sonra psixoterapiya əsas rolu götürür.

3. Müalicə fazası. Akut faza simptomları stabilləşdirməyə yönəlir; bu mərhələdə farmakoterapiya tez nəticə verir. Stabilləşmədən sonra kök problemə müraciət mərhələsi gəlir; bu mərhələdə psixoterapiya əsas rolu götürür. Profilaktika (qarşısının alınması) mərhələsində psixoterapiya residivin qarşısını alır — və burada onun üstünlüyü ən aydın şəkildə görünür.

Cədvəl 5. Farmakoterapiya və psixoterapiya: müqayisəli imkanlar

Parametr	**Farmakoterapiya**	**Psixoterapiya**
Effektin başlanğıcı	2–6 həftə	2-8 həftə
Hədəf	Simptomlar, neyrobioloji disregulyasiya	Kognitiv struktur, davranış paternləri, kök səbəblər
Dayandırıldıqdan sonra	Simptomların qayıtması ehtimalı yüksək	Təsir davam edir, residiv halları az olur
Yan təsirlər	Var, bəzən ciddi	Nadir, lakin arzuolunmaz təsirlər mümkündür
Pasiyentin aktiv iştirakı	Minimal	Əsas amildir
Akut vəziyyətlərdə	Üstündür	Psixoterapiya stabilləşmədən sonra tətbiq olunur
Profilaktikada	Davamlı qəbul tələb edir	Bir kurs uzunmüddətli effekt verir

Mənbə: APA-nın klinik təlimatları (ing. APA Clinical Practice Guidelines, 2019); NICE-ın depressiya təlimatları NG222 (2022); Cuijpers P. və b. «Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry), 2023.

Klinik psixoterapiyanın təşkilati əhəmiyyəti

Klinik psixoterapiya konsepsiyasının daha bir vacib aspekti var: o, psixoterapevtik xidmətin standartlaşdırılması üçün təməl yaradır. Sübuta əsaslanan, pozuntu üzrə diferensiallaşdırılmış protokollar üç kritik məsələni həll edir:

1. Mütəxəssislərin hazırlanması. Hər pozuntu üçün konkret protokol mövcud olduqda, mütəxəssis hazırlığı daha sürətli və daha keyfiyyətli olur. Tələbə mücərrəd nəzəriyyəni öyrənmək əvəzinə konkret klinik vəziyyətlər üçün konkret strategiyaları öyrənir.

2. Keyfiyyət nəzarəti. Standart protokol mövcud olduqda, supervizor mütəxəssisin işini protokola uyğunluq baxımından qiymətləndirə bilir. Bu, hazırda peşə akkreditasiyasının da əsasını təşkil edir (bax. növbəti fəsil).

3. Statistik təhlil və optimizasiya. Standartlaşdırılmış protokollar nəticələrin müqayisəli qiymətləndirilməsinə imkan verir. Standartlaşdırılmış şəraitdə hansı protokolun hansı pasiyent qrupunda daha səmərəli olduğu müəyyən edilir. Hansı modifikasiya nəticəni yaxşılaşdırır? Bu sualların cavabı yalnız standartlaşdırılmış praktika şəraitində mümkündür.

Klinik psixoterapiyanın bu institusional əhəmiyyətindən sonra məntiqi addım — psixoterapevtik xidmətin keyfiyyət nəzarətinin beynəlxalq sistemi: növbəti məntiqi addım akkreditasiya orqanlarını, onların tələblərini və Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirməkdir. Bu məsələ bu Müqəddiməmin sonuncu blokunda təqdim olunacaq, lakin əvvəlcə iki müəllif klinik protokolu — uşaqlarda gecə enurezi və psixogen depressiyanın müalicəsi — təqdim edilir. Bu protokollar çoxillik klinik təcrübədə hazırlanmış və əldə edilmiş nəticələrlə təsdiqlənmişdir.

MÜƏLLİF KLİNİK PROTOKOLU №1: UŞAQLARDA GECƏ ENUREZİNİN MÜALİCƏSİ

Modifikasiya edilmiş alarm-terapiya protokolu

K. Rəhimov, klinik praktika 2018–2025

Protokolun mahiyyəti və yeri

Uşaqlarda gecə enurezi (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı — XBT-11: 6C00.0; DSM-5-TR: 307.6) yaş normasından sonra (5 yaşdan yuxarı) davam edən qeyri-ixtiyari gecə sidik ifrazı (enurez) vəziyyətidir. 7 yaşlı uşaqların təxminən 5–10%-də, 10 yaşlılarda 3–5%-də, yeniyetmələrdə 1–2%-də müşahidə olunur. Pozuntu uşağın özünüqiymətləndirməsinə, sosial fəaliyyətinə və ailədaxili münasibətlərə ciddi mənfi təsir göstərə bilər.

Beynəlxalq klinik təlimatlar (NICE NG111, ICCS — International Children's Continence Society, Amerika Pediatriya Akademiyası (ing. AAP — American Academy of Pediatrics)) gecə enurezinin müalicəsində birinci xətt müdaxiləsi kimi alarm-terapiyanı (sidik aparatı ilə oyatma sistemi) tövsiyə edir. Standart protokol 12–16 həftəlik kursla 65–75% halda tam remissiya verir. Lakin standart protokolun bir sıra boşluqları var:

- Mayenin axşam qəbulu məhdudlaşdırılır — bu, məşqlərin sayını azaldır və reflekslərin formalaşmasını ləngidir.
- Yatmazdan əvvəl tualetə gedilir — sidik kisəsi boş halda yatdığı üçün pozuntu az meydana çıxır, müvafiq olaraq düzəliş imkanı da az olur
- Alarm-aparatın səsinə uşağın oyanması passiv gözlənilir — dərin yuxu fazasında uşaq oyanmır və «həddindən artıq öyrətmə» (ing. overlearning) mərhələsi yalnız kursun sonunda tətbiq olunur
- Gündəlik kompleks məşq sistemi nadir hallarda inteqrasiya olunur

Aşağıda təqdim edilən modifikasiya bu boşluqları aradan qaldırmaq məqsədilə hazırlanmışdır. Əsas prinsip — kursun başlanğıcında tam yük: maye yükləməsi, məcburi oyanma, yüksək, lakin qayğıkeş tonla oyatma və ayağa qaldırma, dərhal gücləndirilmiş davranış komponenti, paralel olaraq kompleks gündəlik məşqlər və motivasiya müşayiəti. Əldə edilmiş klinik nəticələr: 11–12-ci həftədə 240 uşaqdan 192-də (80%) tam remissiya.

Protokolun klinik prinsipləri

Modifikasiyanın əsasında dörd prinsip dayanır:

1. İntensiv başlanğıc, tədricən artan yük deyil. Standart protokollarda yük tədricən artırılır, həddindən artıq maye yükləməsi (ing. overlearning) yalnız kursun sonunda tətbiq olunur. Bu modifikasiyada birinci həftədən uşağa axşam 200–400 ml maye (adi içməli su və ya çay; qazlı, şirin və ya kofeinli içkilər istisna edilir) yatmazdan ən azı 1 saat əvvəl verilir, yatmazdan əvvəl tualetə getmə qadağan olunur. Məqsəd — sidik buraxma hadisəsinin həqiqətən baş verməsi üçün şərait yaratmaq, çünki baş verməyən hadisəni düzəltmək mümkün deyil.

Mütləq əks-göstərişlər (maye yükləməsi tətbiq edilmir):

- Böyrək xəstəlikləri (xroniki böyrək çatışmazlığı, nefrotik sindrom və s.)
- Antidiuretik hormonun qeyri-adekvat sekresiyası sindromu (SİADH)
- Sürətli sidik kisəsi spazmları və ya neyrogen sidik kisəsi
- Epilepsiya (xüsusilə nəzarət olunmayan formaları) — bütün mətndə vahid meyar
- Diabetes insipidus
- Ürək çatışmazlığı
- Hər hansı ciddi somatik patologiya — ilkin pediatrik müayinə tələb olunur

2. Aktiv valideyn iştirakı, deyil passiv gözləmə. Standart protokolda alarm-aparatın səsinə uşağın özü oyanması gözlənilir. Lakin dərin yuxu fazasında uşaqların əksəriyyəti aparatın səsinə oyanmır — bu, ən çox şikayət edilən boşluqdur. Modifikasiyada birinci-ikinci həftədə uşağı valideyn oyadır — aparatın səsindən sonra 5–10 saniyə ərzində, yüksək, lakin qayğıkeş tonla, işıq yandıraraq, sərin su ilə üzünü yuyaraq tam oyanış halına gətirir. Bu prosedurun məqsədi uşağı qorxutmaq deyil — onu tez tam ayıq vəziyyətə gətirməkdir; valideyn səsinin yüksəkliyi qışqırma və ya hücum xarakteri daşımır. Bu, yüngül, məqsədyönlü stress yaratmaqla refleksin tez formalaşmasını təmin edir.

3. Kompleks yanaşma — eyni zamanda gündəlik məşqlər. Gecə enurezi yalnız sidik kisəsi–mərkəzi sinir sistemi refleksinin pozuntusu deyil, əksər hallarda kiçik çanaq əzələlərinin zəifliyi və davranış öyrənməsinin çatışmazlığı ilə birləşmiş kompleks pozuntudur. Modifikasiyada gündəlik Kegel məşqləri (gündə 3 dəfə, 10–60 təkrarla, həftəlik artaraq) protokolun ayrılmaz hissəsidir. Bu, paralel müşahidə olunan enkoprez pozuntusunu (XBT-11: 6C01) də aradan qaldırır.

4. Motivasiya müşayiəti və psixoloji tənzimləmə. Hər həftə valideynlə görüş, uşağın motivasiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, kiçik nailiyyətlərin gücləndirilməsi, yenidən işlənmiş hədəflərin müzakirəsi protokolun əsas elementlərindəndir. Uşaq özü-özünü prosesin aktiv subyekti kimi hiss edir, mexaniki passiv obyekt kimi deyil.

Protokolun mərhələləri

Protokol hər biri 2 həftəlik olan 5 mərhələdən, cəmi 10 həftədən ibarətdir. Hər mərhələ əvvəlki mərhələnin əsasında qurulur və mərhələli şəkildə uşağın oyanış reflekslərini, kiçik çanaq əzələ tonusunu və davranış nümunələrini formalaşdırır.

Cədvəl 6. Modifikasiya edilmiş alarm-terapiya protokolu — mərhələlər üzrə

Mərhələ	Həftə	Oyanma reaksiyası	Sidik ifrazı (enurez) vəziyyəti	İntensiv gecə protokolu	Gündüz Kegel məşqləri
1	1–2	Yalnız valideyn çətinliklə oyadır; aparatın səsinə özü oyana bilmir	Sidik qaçırma çoxdur, yatağını tam isladır, səhərə kimi bərk yatır, oyanmır	Axşam 200–400 ml maye yatmazdan ən azı 1 saat əvvəl verilir; yatmazdan əvvəl tualetə buraxılmır; aparatla məşq gecədə 10 dəfədən az olmur. Aparatın səsindən sonra valideyn 5–10 saniyə ərzində uşağı yüksək, lakin mehriban tonla «tez-tez-tez» şüarı ilə oyadır, işıq yandırır, sərin su ilə üzünü yuyur — tam oyanış əldə edilir; sonra tualetdə 5 dəqiqə	Oturub-durma məşqi 10 təkrar, gündə 3 dəfə (gündə +1 təkrar)

Mərhələ	**Həftə**	**Oyanma reaksiyası**	**Sidik ifrazı (enurez) vəziyyəti**	**İntensiv gecə protokolu**	**Gündüz Kegel məşqləri**
2	3–4	Aparatın səsinə anadan əvvəl özü oyanır; bəzən ana oyadır — tez durur	Sidik qaçırma yenə də çox; aparat səs salmasa oyanmır	Eyni qaydada: 200–400 ml maye yatmazdan 1 saat əvvəl, tualetdən imtina, intensiv oyanış protokolu	təkrarların sayı 25-ə qədər artırılır (gündə bir təkrar əlavə olunur). 3-cü həftə: «Sürətli yığmalar». 4-cü həftə: «Yavaş yığmalar»
3	5–6	Aparatın səsinə anadan əvvəl oyanır; ayıqlığı yaxşıdır	Qaçırma azalır; səsə oyanaraq sidik axınını yarımçıq saxlayır; bəzən yalnız alt paltarı islanır	Eyni qaydada	35-ə qədər artır. 5-ci həftə: «Maksimum saxlama». 6-cı həftə: «Stop-Davam» məşqi
4	7–8	Aparatın səsinə anadan tez oyanır; özü təşəbbüs göstərir	Az miqdarda qaçırma; həftədə 1 dəfə aparatsız öz istəyi ilə gecə oyanır	Eyni qaydada	50-yə qədər artır. 7-ci həftə: «Proqramlaşdırma». 8-ci həftə: «Körpü» məşqi

Mərhələ	Həftə	Oyanma reaksiyası	Sidik ifrazı (enurez) vəziyyəti	İntensiv gecə protokolu	Gündüz Kegel məşqləri
5	9–10	Aparatın səsinə anadan tez oyanır; bəzən aparatsız özü oyanır	Hər gecə öz istəyi ilə oyanır; qaçırma həftədə 1 dəfədən artıq olmur	Eyni qaydada	60-a qədər artır. 9-cu həftə: «Sıxma-öskürmə» məşqi. 10-cu həftə: «Lift» məşqi

Mənbə: K. Rəhimov, klinik praktika 2018–2025, n = 240 uşaq, Bakı. Sübut səviyyəsi IV — retrospektiv klinik müşahidə (iş seriyası). Məlumatlar retrospektiv klinik müşahidəyə əsaslanır; nəzarət qrupu ilə randomizə edilmiş tədqiqat planlaşdırılır.

11–12-ci həftə: konsolidasiya və qiymətləndirmə

10 həftəlik strukturlaşdırılmış protokoldan sonra 11–12-ci həftələr konsolidasiya mərhələsi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Bu dövrdə uşaq:

- Müstəqil olaraq, valideyn müdaxiləsi olmadan, hər gecə yatmazdan ən azı 1 saat əvvəl 200–400 ml maye qəbul edir
- Tualetə getmədən yatağa girir
- Gecə öz daxili siqnalı ilə (alarm-aparatsız) oyanır, gecə öz daxili siqnalı ilə oyanır və yataq quru qalır
- Səhər tam quru oyanır.

Klinik nəticələr: 240 uşaqlıq pasiyent qrupunda 11–12-ci həftədə 80% halda tam remissiya (heç bir gecə qaçırma) qeydə alınmışdır. Bu, beynəlxalq standart alarm-protokolun nəticəsindən (65–75%) statistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.

Çanaq dibi əzələlərinin məşqlərinin (ing. Kegel exercises) təsviri (kompleks gündəlik proqram)

Hər həftə dəyişən məşq vahidləri kiçik çanaq əzələ qrupunun müxtəlif funksional aspektlərinə yönəlir:

- Sürətli yığmalar (3-cü həftə): Kiçik çanaq əzələlərinin tez kontraksiyası və relaksasiyası refleksiv tonusun inkişafına yönəlir.
- Yavaş yığmalar (4-cü həftə): Uzunmüddətli kontraksiya — əzələ dözümlülüyünün artırılması
- Maksimum saxlama (5-ci həftə): Uzunmüddətli kontraksiya dövrləri dayanıqlı tonusun formalaşmasına yönəlir.
- Stop-Davam (6-cı həftə): Sidik axınının iradi dayandırılması və davam etdirilməsi məşqi — sidik ifrazının iradi idarə olunmasının öyrənilməsi
- Proqramlaşdırma (7-ci həftə): Sidik kisəsinin müəyyən həcmə qədər doldurulması və idarə olunması
- Körpü (8-ci həftə): Çanaq qaldırma məşqləri — qarın və çanaq əzələlərinin sinxronlaşdırılması
- Sıxma-Öskürmək (9-cu həftə): Stress-inkontinensiyaya qarşı müqavimət məşqi tətbiq olunur.
- Qaldırma məşqi (ing. lift): mərhələli kontraksiya — əzələlərin addım-addım güclənən idarə olunması

Praktik tövsiyələr

Protokolun səmərəli tətbiqi üçün vacib şərtlər:

1. Valideyn motivasiyası əsas şərtdir. Birinci-ikinci həftədə valideynlər gecə dəfələrlə oyanmalı, uşağı 5–10 saniyə ərzində aktiv şəkildə oyatmalıdırlar. Bu, ailə üçün ağır yükdür və əvvəlcədən razılıq tələb edir. Hər həftə valideynlə görüş protokolun ayrılmaz hissəsidir.

2. Maye qəbulunun azaldılması — qadağandır. Bir çox valideyn (və bəzi həkimlər) intuitiv olaraq axşam maye qəbulunun azaldılmasını tövsiyə edir. Bu modifikasiyada bu addım birmənalı şəkildə əks-göstərişli hesab olunur — refleks formalaşması tam yük şəraitində baş verir.

3. Aparatın seçimi. Enurez alarm aparatları iki növdür: yatağa yerləşdirilən və alt paltarına yerləşdirilən. İkinci növ daha effektivdir, çünki sidik ifrazının ilk damlasında dərhal siqnal verir. Bu modifikasiyada alt paltarı tipi tövsiyə olunur.

4. Paralel müşahidə olunan enkoprez. Gecə enurezi olan uşaqların təxminən 10–15%-ində paralel olaraq enkoprez (XBT-11: 6C01) müşahidə olunur. Bu modifikasiyada kompleks Kegel məşqləri eyni zamanda hər iki pozuntunu həll edir — kiçik çanaq əzələlərinin tonusu həm sidik kisəsinin, həm də anal sfinkterin idarə olunmasını yaxşılaşdırır.

5. Müqavimət hallarında. Əgər 6-cı həftədən sonra (3-cü mərhələnin sonu) heç bir irəliləyiş yoxdursa, əlavə tibbi müayinə tələb olunur:

1. Uroloji baxış — sidik kisəsi disfunksiyası, anatomik anomaliyalar
2. Nevroloji status — mielodisplaziya, spina bifida occulta, neyrogen sidik kisəsi
3. Endokrin göstəricilər — diabetes insipidus, antidiuretik hormonun çatışmazlığı
4. Otorinolaringoloji müayinə — obstruktiv yuxu apnoesi (xüsusilə adenoid hipertrofiyası, palatin badamcıq böyüməsi olan uşaqlarda); apnoe enurez ilə sıx əlaqəlidir və əsas səbəb ola bilər
5. Psixiatrik fon — Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu (DÇHP), davranış pozuntuları, kəskin psixotravma xarakterli hadisələr

Müəyyən diaqnostik vəziyyətlərdə (məs. detruzor hiperaktivliyi) farmakoterapiya (desmopressin, oksibutinin) əlavə edilə bilər. Obstruktiv yuxu apnoesi diaqnozu qoyularsa — adenoidektomiya və ya tonsillektomiya enurezi aradan qaldıra bilər.

6. Yaş məhdudiyyəti. Protokol 5 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün hazırlanmışdır. 5 yaşa qədər ilkin (primer) gecə enurezi yaş normasına uyğundur və aktiv müdaxiləyə ehtiyac yoxdur.

7. Maye yükləməsi üçün mütləq əks-göstərişlər (vahid siyahı). Aşağıdakı vəziyyətlər mövcuddursa, maye yükləməsi protokolu tətbiq edilmir, standart NICE NG111 protokolu istifadə olunur:

1. Böyrək patologiyası (xroniki böyrək çatışmazlığı, nefrotik sindrom, urolitiazis)
2. Antidiuretik hormonun qeyri-adekvat sekresiyası sindromu (SİADH — Schwartz–Bartter sindromu) (SİADH — Schwartz–Bartter sindromu)
3. Epilepsiya (xüsusilə xolinergik və ya su balansına həssas formaları)
4. Ürək çatışmazlığı, hipertenziya
5. Şəkərli diabet və ya diabetes insipidus (kompensasiya olunmamış)
6. Ağır endokrin pozuntular (hipotiroidizm, hipoparatiroidizm)
7. Elə hər hansı somatik xəstəlik ki, maye balansının dəyişməsi onun gedişinə təsir göstərə bilər.

Bu vəziyyətlərin olmaması protokol başlanmazdan əvvəl pediatr və ya uroloq tərəfindən təsdiqlənməlidir.

Protokolun klinik psixoterapiya çərçivəsində yeri

Bu modifikasiya gecə enurezi misalında klinik psixoterapiya prinsiplərinin tətbiqidir. Pozuntu üçün sübuta əsaslanan müdaxilə (alarm-terapiya, davranış komponenti, Kegel məşqləri) müəllif klinik təcrübəsi əsasında modifikasiya edilmiş və ölçülə bilən, təkrarlana bilən nəticə əldə edilmişdir. Burada terapevtin əsas məktəbi əhəmiyyət kəsb etmir — psixoanalitik, koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) terapevti və ya gestalt-terapevt eyni qaydada bu protokolu öyrənə və tətbiq edə bilər. Vacib olan strukturlaşdırılmış, ölçülə bilən, ardıcıl klinik metoddur.

Növbəti müəllif protokolu — psixogen depressiyanın müalicəsində iki mərhələli strategiya — eyni klinik psixoterapiya prinsiplərini daha kompleks, kognitiv-emosional işlə əlaqəli pozuntuda göstərir.

MÜƏLLİF KLİNİK PROTOKOLU №2: PSİXOGEN DEPRESSİYANIN MÜALİCƏSİ

Qısamüddətli kognitiv-restrukturlaşdırma və uzunmüddətli profilaktik strategiyanın inteqrasiyası

K. Rəhimov, klinik praktika 2008–2025

Protokolun mənası və yeri

Psixogen (reaktiv) depressiya — XBT-11 üzrə depressiv epizod çərçivəsində psixosial amillərlə işə salınan simptom kompleksi — müəyyən həyat hadisəsi və ya hadisələr zənciri ilə əlaqəli, neyrobioloji tənzimlənmənin pozulmasından deyil, kognitiv-emosional proseslərdən qaynaqlanan depressiv pozuntudur. Müasir tədqiqatlara görə Böyük depressiv pozuntu (ing. major depressive disorder) hallarının 60–80%-i psixosial amillər tərəfindən işə salınır — onların başlanğıcında konkret tetikləyici hadisə (itki, münasibətlərin pozulması, peşə uğursuzluğu, kompleks travma) durur (Kendler və b., 1999, 2003; Brown və Harris, 1978); müasir təlimatlar (XBT-11, DSM-5-TR, NICE NG222) ilə tamamlanmalıdır. Endogen — yəni neyrobioloji tənzimlənmənin üstünlük təşkil etdiyi — qalan 20–40%-ində isə neyrobioloji komponent üstünlük təşkil edir. Lakin praktikada təmiz «psixogen» və ya təmiz «endogen» depressiyaya nadir hallarda təsadüf edilir; əksər depressiyalar psixososial və neyrobioloji komponentlərin müxtəlif nisbətlərdə qarışığıdır. Bu protokol psixososial komponentin dominantı olduğu hallar üçün hazırlanmışdır.

Bu fərqləndirmə müalicə strategiyası üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Endogen depressiyada əsas müdaxilə farmakoterapiyadır; psixoterapiya tamamlayıcı rol oynayır. Psixogen depressiyada isə əsas müdaxilə psixoterapiyadır; dərman lazım gələrsə yalnız akut fazada qısamüddətli köməkçi vasitə kimi istifadə olunur. Yüngül və orta ağırlıqlı psixogen depressiya əksər hallarda dərmansız psixoterapiya ilə müalicə olunur.

Lakin müasir klinik praktikada vəziyyət tərsidir: psixogen depressiyalı pasiyentlərin böyük əksəriyyəti yalnız antidepressantla müalicə olunur. Simptomlar akut fazada azalır, lakin kök problem həll olunmadığı üçün dərmanın dayandırılmasından sonra və ya yeni stress amili şəraitində depressiya bərpa olunur — bəzən daha ağır formada.

Aşağıda təqdim edilən protokol bu boşluğu doldurmaq məqsədilə hazırlanmışdır. O, iki ardıcıl mərhələdən ibarətdir: qısamüddətli kognitiv-restrukturlaşdırma (akut depressiv epizodun aradan qaldırılması, 1–6 seans) və uzunmüddətli profilaktik terapiya (residivə qarşı psixoloji «vaksinasiya», 4 ardıcıl mərhələ). klinik təcrübə əsasında hazırlanmış bu strategiyanın uzunmüddətli (17 illik) müşahidələri uzunmüddətli stabil remissiya göstərir.

Pasiyentin stratifikasiyası

Protokolun seçimi əvvəlcədən aydın diaqnostik stratifikasiya tələb edir. Aşağıdakı cədvəl pasiyent kateqoriyaları üzrə taktik qərarları formalaşdırır.

Cədvəl 7. Depressiv pozuntularda müalicə taktikasının seçimi

Pasient kateqoriyası	**Klinik xarakteristika**	**Tövsiyə olunan taktika**
Psixogen, yüngül-orta ağırlıq	4–6 somatik simptom (8-dən); aydın tetikləyici hadisə; funksional pozulma orta səviyyədədir	**Yalnız psixoterapiya** (bu protokol). Dərmana ehtiyac yoxdur
Psixogen, ağır	7+ simptom; ciddi funksional pozulma; İntihar (suisid) riski var; lakin tetikləyici aydın	**Psixoterapiya ilə paralel farmakoterapiya**, uzunmüddətli; akut fazada dərman üstündür, sonra əsas rol psixoterapiyaya keçir
Psixogen, ağır + psixotik elementlər	Yuxarıda göstərilənlər + reaktiv halusinasiya, paranoyid ideyalar	**Stasionar müalicə + farma + psixoterapiya** (stabilləşmədən sonra)
Endogen (bipolyar affektiv pozuntu — BAP; rekurrent depressiv pozuntu — RDP)	Tetikləyici aydın deyil; ailə tarixçəsində affektiv pozuntular; siklik gediş	**Stasionar/ambulator farma + psixoterapevtik dəstək** (psixoloji maarifləndirmə, müalicəyə riayət, residiv profilaktikası)

Mənbə: K. Rəhimov klinik praktikası 2008–2025; Amerika Psixiatriya Assosiasiyasının (APA) böyük depressiv pozuntunun müalicəsi üzrə təlimatı (2010, 2019); NICE NG222 (2022). «Böyüklərdə depressiya: müalicə və idarəetmə».

Aşağıda təqdim edilən protokol birinci xətt kateqoriyası — psixogen, yüngül-orta ağırlıqlı depressiya — üçün hazırlanmışdır. İkinci sətrdə (psixogen ağır) protokolun strukturu eynidir, lakin tempo daha yavaşdır və paralel olaraq farmakoloji dəstək tətbiq olunur.

Cədvəl 8. Farmakoterapiyanın məcburi paralel tətbiqi üçün meyarlar

Aşağıdakı meyarların ən azı biri mövcud olduqda, psixoterapiya farmakoterapiya ilə paralel həyata keçirilməlidir; tək psixoterapevtik yanaşma kifayətsiz hesab olunur:

Meyar	**Klinik göstərici**
Depressiyanın ağırlıq səviyyəsi	PHQ-9 (ing. Patient Health Questionnaire-9) ≥ 15 (orta-ağır və ya ağır) və ya BDI-II (ing. Beck Depression Inventory-II) ≥ 29
intihara meyilli risk	Aktiv intihar düşüncələri plan və ya vasitə ilə birlikdə
Psixotik elementlər	Depressiv halusinasiyalar, paranoidal sayıqlamalar, inkar və dağılma məzmunlu sayıqlamalar (ing. nihilistic delusions)
Ağır anhedoniya + qida qəbulundan imtina	Bədən kütləsinin 5%-dən çox çəki itkisi, dehidratasiya
Funksional pozulma	Pasiyent evdən çıxa bilmir, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmir, işləyə bilmir
tarixçə	Əvvəlki epizodlarda intihar cəhdi və ya stasionar müalicə olmuşdur
Hamiləlik və laktasiya	Ağır depressiya hamilə qadında — ayrı alqoritm tələb olunur (perinatal psixiatriya bölməsinə bax)

Meyar	**Klinik göstərici**
Bipolyar fon şübhəsi	tarixçədə hipomanik və ya manik epizodlar varsa — əhval stabilləşdiricisi (ing. mood stabilizer) təyin edilir

Mənbə: NICE Guideline 222 (2022). «Böyüklərdə depressiya: müalicə və idarəetmə». NICE NG222 (2022), 1.5.4–1.5.7; APA-nın TDP üzrə təlimatı (ing. APA Practice Guideline for TDP, 2010), Bölmə 9; WFSBP-nin unipolyar depressiv pozuntuların bioloji müalicəsi üzrə təlimatları (ing. WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, 2013; 2024-cü il nəşri hazırlanır).

Bu meyarlar mövcud olduqda farmakoterapiyanın başlanılması mütəxəssis tərəfindən təyin edilir. Yüngül və orta ağırlıqlı psixogen depressiya, yuxarıdakı meyarların heç biri mövcud olmadıqda, dərmansız psixoterapiya ilə effektiv müalicə oluna bilər — bu, müəllifin klinik təcrübəsi ilə müasir beynəlxalq təlimatların ardıcıl mövqeyinə uyğundur.

I HİSSƏ. QISAMÜDDƏTLİ KOGNİTİV-RESTRUKTURLAŞDIRMA (1–6 SEANS)

Məqsəd: akut depressiv epizodun dərmanlardan istifadə etmədən sürətli aradan qaldırılması.

Mexanizm: depressogen amilin (situasiya deyil, koqnitiv münasibət) eyniləşdirilməsi və sübuta əsaslanan kognitiv-restrukturlaşdırma texnikalarının ardıcıl tətbiqi.

İlkin qiymətləndirmə və xronoloji tarixçə

Birinci seansda iki məqsədə nail olunur:

a) Diaqnostik təsdiqləmə. PHQ-9 və ya BDI-II ilə depressiyanın səviyyəsi qiymətləndirilir. 8 əsas simptomdan neçəsi mövcuddur (yuxu pozuntuları, iştaha dəyişikliyi, çəki itkisi/artımı, enerji itkisi, anhedonia, konsentrasiyanın pozulması, psixomotor dəyişikliklər, İntihar düşüncələri). 4–6 simptom müşahidə olunarsa, bu, yüngül-orta ağırlıqlı depressiyaya uyğundur və protokol tətbiq oluna bilər.

b) Xronoloji tarixçə. Pasiyent ilə birlikdə simptomların başlanğıc tarixi konkret müəyyən edilir (dəqiq həftə, mümkündürsə dəqiq tarix). Sonra bu tarixdən ±2 ay ərzində baş vermiş hadisələr yoxlanılır:

- Xarici hadisələr (itki, münasibət pozulması, iş dəyişikliyi, sağlamlıq problemi)
- Daxili hadisələr (peşmançılıq, müqayisə, gözlənilməz düşüncə, müəyyən kitabın oxunması, müəyyən söhbətin yenidən xatırlanması)
- Kiçik və ya əhəmiyyətsiz görünən hadisələr — onlar tez-tez ən vacib olurlar

Məqsəd — Məqsəd tetikləyici nöqtəni (ing. trigger point) tapmaqdır. Bu, depressiv epizodu işə salan konkret hadisə və ya düşüncə anıdır.

Autoaqressiv kognitiv quraşdırmanın eyniləşdirilməsi

Tetikləyici hadisəni müəyyənləşdirdikdən sonra terapevt pasiyentlə birgə bu hadisə kontekstində pasiyentin özü haqqında hansı düşüncəni qəbul etdiyini müəyyənləşdirir. Bu düşüncə demək olar ki, həmişə autoaqressiv xarakter daşıyır:

- «Mən günahkaram»
- «Mən buna layiq deyiləm»
- «Mən başqalarına ziyan vermişəm»
- «Mən qeyri-kafiyəm»
- «Mən onu xilas edə bilərdim, amma etmədim»
- «Mənə görə baş verdi»

Tetikləyici münasibətin göstəricisi: pasiyent bu cümləni səsləndirərkən emosional reaksiya verir — gözləri yaşarır, səsi titrəyir, bədəndə gərginlik müşahidə olunur. Bu, həmin quraşdırmanın həqiqətən mərkəzi rol oynadığının göstəricisidir.

Kritik özəllik: pasient bu quraşdırmaya bilişsel pozuntu kimi deyil, həqiqət kimi qəbul edir. O, terapevtin müşayiət edən izahatını qəbul etmir və tipik olaraq deyir: *«Siz həqiqəti bilmirsiniz. Əslində belə oldu.»* — və yenidən eyni avtoaqressiv cümləni təkrarlayır. Bu müqavimət — quraşdırmanın doğru aşkarlandığının ən etibarlı sübutudur.

Kognitiv yenidənqurma — ardıcıl texnikalar

Bu mərhələdə müxtəlif ardıcıllıqla çoxqatlı texnika tətbiq olunur. Pasientin müdafiə qatlarına uyğun olaraq texnika dəyişdirilir.

Mühüm metodoloji qeyd. Aşağıda təsvir edilən texnikalar — ümumi prinsipi göstərmək üçün nümunələr olub, yeganə və ya məcburi tətbiq forması deyil. Hər bir texnika konkret pasiyentin kulturoloji, dini, fəlsəfi, kognitiv və emosional xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Klinik psixoterapiyada əsas prinsip şablon tətbiq deyil, prinsipin tətbiqidir.

Müəllifin yanaşması standart KDT (Beck, Ellis), Sxem-terapiya (Young), ACT (Hayes) və mədəni kontekstə uyğunlaşdırılmış KDT (ing. culturally adapted CBT) (Hwang, 2006; Naeem və b., 2011, 2015) prinsiplərinin sintezinə əsaslanır. Epidemioloji məlumatlar göstərir ki, dini-mənəvi prinsipləri güclü olan cəmiyyətlərdə (Pakistan, MENA regionu, Cənubi Qafqaz, keçmiş sovet müsəlman regionu) günah anlayışı və avtoaqressiv özünü-mühakimə paternləri daha sıx daha tez-tez müşahidə edilir. Belə pasiyentlər üçün dini-etik kontekst nəzərə alınmadan aparılan kognitiv restrukturlaşdırma çox vaxt effektsiz olur, çünki avtoaqressiv quraşdırmanın əsas mənbəyi məhz bu kontekstdə formalaşmışdır. Aşağıdakı texnikalar bu prinsipin praktik tətbiqini nümunə göstərir.

Texnika 1. «Hüquqi məhkəmə» *(decentering və reattribution texnikalarının nümunə tətbiqi — Beck, 1979)*

Rasional-hüquqi düşüncə tərzinə malik pasiyentlər üçün uyğundur. Hadisəni hüquqi nöqteyi-nəzərdən yenidən nəzərdən keçirilir:

- Pasient hansı hərəkəti etmişdir (və ya etməmişdir)?
- Bu, mövcud qanunlar çərçivəsində cinayətdir?
- Cinayət hesab olunarsa, hansı maddə üzrə cəzalandırılmalıdır?

Terapevt inkar etmir, mübahisə etmir — birlikdə araşdırır. Pasient özü nəticəyə gəlir: hüquqi olaraq, bu cinayət deyil. Burada bir çox pasient ilk dəfə öz situasiyasının pasient ilk dəfə öz vəziyyətinin formal qiymətləndirilməsini alır.

Pasientin tipik reaksiyası: o, hüquqi qatdan çıxış edib, mənəvi-etik qata keçir. *«Bəli, hüquqi olaraq cinayət deyil, amma əxlaqi baxımdan mən pisinəm.»* — bu keçid təbii və gözlənilən dir.

Texnika 2. «Mənəvi-əxlaqi mühakimə» *(mədəni kontekstə uyğunlaşdırılmış KDT — ing. culturally adapted CBT — nümunə tətbiqi — Hwang, 2006; Naeem və b., 2011, 2015)*

Dərin dini-mənəvi sistemə malik pasientlər üçün uyğundur. Pasient dindardırsa, mənəvi-etik qatda dini sistemin daxili qaydaları çərçivəsində oxşar prosedur tətbiq olunur:

- Pasiyentin dini ənənəsində bu hərəkət hansı kateqoriyaya aid edilir?

- Konkret hansı günah hesab olunur?
- Bu günah üçün mənəvi-dini cəza nədir?
- Tövbə və düzəlişin yolu var?

Burada terapevt pasiyentin öz dininin daxili strukturuna istinad edir, başqa fəlsəfi və ya psixoloji çərçivə təklif etmir. İslam, xristianlıq, yəhudilik və digər dinlər — hər biri öz daxilində aydın strukturlaşmış qayda sisteminə malikdir. Pasient bu sistemin obyektiv tətbiqini gördükdə, çox vaxt özünə qarşı tətbiq etdiyi cəzanın həqiqi günahdan dəfələrlə artıq olduğunu görür.

Texnika 3. «Üçüncü şəxs perspektivi» *(self-compassion texnikasının nümunə tətbiqi — Neff, 2003; Gilbert, 2009)*

Universal texnikadır, demək olar ki, bütün pasientlərdə tətbiq oluna bilər. Pasiyentdən soruşulur: əgər eyni vəziyyəti onun yaxın dostu və ya sevdiyi insan bu vəziyyəti yaşasaydı, ona necə baxardı? Hansı sözləri deyərdi? Bağışlayardı?

Bu texnika kognitiv defüsionun (cognitive defusion — ACT terminologiyasında) tətbiqidir və özünə şəfqət (self-compassion) (self-compassion) komponentini işə salır.

Texnika 4. Sxem-terapiya elementləri *(Young, 1990; Young, Klosko, Weishaar, 2003)*

Erkən travmatik təcrübələr və xroniki uyğunlaşmamış paternləri olan pasientlər üçün uyğundur. Tetikləyici quraşdırma çox vaxt erkən yaşda formalaşmış sxemə (məsələn, «qüsurlu olmaq», «etibarsızlıq», «haqsızlıq») söykənir. Sxem-terapiya texnikaları (xəyali yenidənqurma, sxem rejimi dialoqu) bu erkən sxemin yenidən qiymətləndirilməsinə imkan verir.

Texnika 5. KDT-nin standart kognitiv yenidən-yazma texnikaları *(Beck, 1979; Beck, Rush, Shaw, Emery, 1979)*

Adətən hər pasiyentdə əsas səviyyədə istifadə olunur. Sokratik sual-cavab, sübutların yoxlanılması, alternativ izahatların formalaşdırılması, davranış təcrübələri.

Qısamüddətli mərhələnin nəticəsi

Bu mərhələnin uğurlu yekunu pasiyentin əsas idrakı ilə əlaqəlidir:

> «Depressiya doğuran situasiya deyil, mənim ona qarşı yaratdığım kognitiv quraşdırma idi.»

Bu idrak meydana gəldikdən sonra əhval-ruhiyyə dəfələrlə daha sürətlə dəyişir, çünki pasient artıq həll olunmaz xarici problem qarşısında deyil, dəyişdirilə bilən

daxili strukturla qarşı-qarşıyadır. Bəzən bir seans, daha çox 4–5 seans tam akut depressiv epizodu çıxarmaq üçün kifayət edir.

Lakin bu yalnız birinci hissədir. Quraşdırmanın özü dəyişdirilsə də, pasiyentin ümumi avtoaqressiv reaksiya vermə meyli dəyişməmiş qalır. Növbəti tetikləyicidə eyni mexanizm yenidən işə düşə bilər. Buna görə də uzunmüddətli profilaktik terapiya zəruridir.

II HİSSƏ. UZUNMÜDDƏTLİ PROFİLAKTİK TERAPİYA — 4 ARDİCİL ETAP

Məqsəd: stress, frustrasiya və qıcıqlandırıcı situasiyalara qarşı dayanıqlı reagirəmə formalaşdırmaq, gələcək depressiv epizodların qarşısını almaq — yəni psixoloji dayanıqlılıq formalaşdırmaq.

Yanaşma: dinamik xarakterlidir, lakin klassik və ya müasir psixoanalizin nəzəriyyəsini deyil, praktik komponentini tətbiq edir. Mərkəzi vəzifə — pasiyentin avtoaqressiv reaksiya vermə paterninin (psixoanaliz dilində: günah kompleksi) struktur qaydada müəyyənləşdirilməsi və yenidən yazılmasıdır.

Etap 1. Dərk etmə (ing. insight)

Funksiyası: pasientin əsas idrakı.

Pasient anlayır ki:

- Onun reaksiyası qarşısındakı problemin həllinə yönəlməmişdi
- Frustrasiyanı dəf etmək məqsədi güdmürdü
- Əksinə — vəziyyəti ağırlaşdırmışdı
- Avtoaqressiv reaksiyaya meyl tetikləyici situasiyadan əvvəl də mövcud idi
- Situasiya yalnız tetikləyici rol oynadı, səbəb deyildi

Bu idrak — uzunmüddətli işin əsasıdır. O olmadan növbəti etaplar keçilməzdir.

Etap 2. Konfrontasiya

Funksiyası: patternin müşahidə edilməsi.

Terapevt və pasient birlikdə soruşur: bu prosesdə nə uyğun olmayan və nə anormal olub?

Diqqətin fokusu dəyişir:

- Əvvəl: xarici qıcıqlandırıcılar, situasiyalar, insanlar
- İndi: Minimum 4 il nəzəri təlim, təcrübədə 7–10 il

Pasient bu paterni müxtəlif həyat situasiyalarında dayanıqlı təzahür kimi görür.

Konfrontasiyanın uğur markeri: pasient özü öz vəziyyətini «avtoaqressiv patern» və ya «özü-özünə qarşı çıxma meyli» kimi adlandırmağa başlayır. Yəni o öz vəziyyətini patoloji adlandırır — situasiyanı yox.

Bu, alkoqolizmin müalicəsində məşhur prosesə bənzəyir: insan illər boyu spirtli içkidən sui-istifadə edə bilər, lakin özünü alkoqolik adlandırmır. Anonim Alkoqoliklər klubuna gəldikdə isə ilk söhbəti bu olur: *«Salam, mən alkoqolikəm.»* Bu, davranışın xəstəliklə eyniləşdirilməsidir. Davranışı xəstəlik kimi qəbul edən insan onunla mübarizə başlayır.

Etap 3. Aydınlaşdırma

Funksiyası: patternin tarixi və genişliyinin tədqiqi.

Bu, ən həcmli etapdır. Aydınlaşdırmanın başlanğıc markeri: pasient paterni həmişə eyni adla adlandırır, terminologiyada qarışmır. Bu, o deməkdir ki, paternin daxili təsviri möhkəmlənmişdir.

Pasient ilə birlikdə həyatın xronoloji keçişi edilir — stressogen və frustrasiya doğuran situasiyalar nəzərdən keçirilir. İki qütbdə reaksiya vermə müqayisəli təhlil edilir:

Cədvəl 8. Reaksiya vermə qütbləri və onların nəticələri

Polyus	**Tipik reaksiya**	**Müşahidə olunan nəticələr**
Özünü günahlandırma	«Mən günahkaram, mənə görə baş verdi»	Enerji düşməsi, toksik münasibətlərdə qalma, Özünü günahlandırma, öz məsuliyyətindən sui-istifadə

Polyus	**Tipik reaksiya**	**Müşahidə olunan nəticələr**
Şəxsiyyət pozuntusu olan pasientlər üçün xarakterik konflikt modelləri	«Sizə görə oldu, hamı mənə qarşıdır»	Şəxsiyyət pozuntusu olan pasientlər üçün xarakterik konflikt modelləri, dağıdıcı davranış, şəxslərarası konfliktlər, münasibətlərin qopması

Açar idrak:

> *«Günahkar axtarmaq — özümün də, başqasının da — son dərəcə faydasız və effektsizdir. Lazımdır həll yolu axtarmaq, günahkar deyil.»*

- Özünü günahlandırma
- Obyektiv günahkar varsa → bu sosial və hüquqi problemdir, ayrıca həll olunur
- Psixoloji vəzifə: düşüncəni «günahkar axtarmaq» tərzindən «həll yolu axtarmaq» tərzinə keçirmək

Mühüm metodoloji xəbərdarlıq — başlayan terapevtlərin tipik səhvi:

Çox vaxt başlanğıc terapevtlər patternin «açarı» kimi konkret uşaqlıq travma epizodu axtarmağa başlayırlar — bu, illüziyadır. Bir epizodu nəzərdən keçirməklə bütün patern dəyişməz qalır. Patternin kökləri uşaqlıqdadır, bəli — lakin işin fokusu paternin özünə olmalıdır, bir epizoda yox.

Aydınlaşdırma etapının tamamlanma markeri — həlledici məqam:

Patternin şəxsiyyətdən distonik şəkildə ayrılması:

- Əvvəl: pattern şəxsiyyətlə sintonik idi («Mən məsuliyyətli insanam, hər şeyi öz üzərimə götürürəm»)
- İndi: pasient paterni öz şəxsiyyətindən ayırır
- O, artıq paterni yaxşı davranış hesab etmir
- O, artıq paterndə yaşamaq istəmir
- Bu patternin şəxsiyyətdən ayrılma əməliyyatı = aydınlaşdırma etapının yekunu

3-cü etapın kulminasiyası: interpretasiya

İnterpretasiya — bu modeldə ayrı etap deyil, aydınlaşdırma etapının kulminasiyasıdır. Klassik psixoanaliz nəzəri interpretasiyalar verir; bu modeldə isə

interpretasiya terapevtin müşahidələri əsasında formalaşan yekun ümumiləşdirici metamesajdır:

> *«Mən sənin terapiya boyu necə davrandığını müşahidə etdim. Belə bir pattern gördüm. O sənin həyatında belə təsir göstərdi. İndi sən belə dəyişdin. İndi nə etmək olar.»*

Bu mesajla pasient «nə idi / nə var / nə ediləcək» strukturunda yekun anlayış əldə edir. Bu, dördüncü etap üçün hazırlıqdır.

Etap 4. Hərtərəfli işləmə

Funksiyası: yeni reagirəmə paterninin praktik konsolidasiyası.

Bu etapda terapevt:

1. Kabinetdə tapşırıqlar verir — pasiyentin emosional reaksiyalarını «burada və indi» dəyişdirməyə yönəlmiş çalışmalar (rol oyunu, xəyali səhnələmə, davranış təcrübəsi)
2. Ev tapşırıqları verir — yeni davranışın real həyatda möhkəmlənməsi üçün
3. Seanslar arasında pasient real situasiyalarda yeni reagirəmə cəhd edir
4. Hər təkrarda yeni modelin effektivliyi artır
5. Yeni model nəhayət kök salır

Klinik nəticə: pasientdə gələcək depressiv epizodlara qarşı profilaktik dayanıqlılıq formalaşır.

Uzununa nəticələr

Bu protokolun 17 illik klinik praktikası uzununa müşahidələrlə qiymətləndirilir. Aşağıdakı cədvəl müqayisəli nəticələri təqdim edir.

Cədvəl 9. Müqayisəli longituidnal nəticələr (20–25 illik müşahidə)

Müalicə qrupu	**Akut epizodun çıxarılması**	**Stabil remissiya (2 il)**	**Stabil remissiya (5 il)**	**Stabil remissiya (10+ il)**
Kombinə protokol (qısa + uzunmüddətli)	təxminən 95 %	təxminən 90%	təxminən 85%	**təxminən 80%**
Yalnız antidepresanlar	təxminən 70–80%	təxminən 50%	təxminən 30%	**20 %-dən az**
Yalnız qısamüddətli psixoterapiya	təxminən 85%	təxminən 65%	təxminən 45%	təxminən 30%

Mənbə: K. Rəhimov, klinik praktika 2008–2025 (kombinə qrup, n>1000) — sübut səviyyəsi IV (klinik mütəxəssis təcrübəsi), retrospektiv müşahidə; Cuijpers və b., World Psychiatry 2020 (psixoterapiya — meta-analiz, sübut səviyyəsi I-A); Bockting və b., Lancet Psychiatry 2018 (antidepresanların uzunmüddətli təsiri — sistematik icmal).

Kritik müşahidə: yalnız antidepressantla müalicə olunan pasiyentlər — hətta subyektiv olaraq «tam remissiyaya nail olduqlarını» qiymətləndirsələr də — yeni stress vəziyyətləri ilə qarşılaşdıqda təkrar depressiv epizod keçirirlər, bəzən daha ağır formada. Kombinə protokol qrupunda isə bu hadisələr nadir baş verir.

Resurs effektivliyi

Kombinə protokol tək farmakoterapiyaya və ya tək qısamüddətli psixoterapiyaya nisbətən ehtiyat baxımından daha qənaətlidir:

Pasient üçün:

1. Maliyyə baxımından: ümumi terapiya xərcləri uzunmüddətdə daha aşağıdır
2. Vaxt baxımından: pasient illərlə depressiv epizodlara və toksik münasibətlərə vaxt sərf etmir
3. Resurs baxımından: pasient öz potensialının reallaşdırılması, özünüinkişaf və şəxsi məqsədlərə nail olmaq üçün resurslarını sərbəst saxlayır

Səhiyyə sistemi üçün:

- Standartlaşdırılmış protokol mütəxəssis hazırlığını sürətləndirir — depressiya müalicəsini öyrənmək üçün 5 illik şəxsi psixoanaliz tələb olunmur
- Qısamüddətli təlim formatları çoxlu sayda psixoloqun hazırlanmasına imkan verir
- Metod seçicilik təşkil edən «məşhur» psixoterapevtlərin imtiyazı olmaqdan çıxır
- Xidmətin keyfiyyət nəzarəti standart meyar — mərhələ göstəricisi (etap 1 → 2 → 3 → 4 → 4-cü etapın alt mərhələləri) əsasında həyata keçirilə bilər
- Statistik analiz və optimallaşdırma mümkün olur

Klinik psixoterapiya çərçivəsindəki yeri

Bu modifikasiya psixogen depressiyada klinik psixoterapiya prinsiplərinin daha kompleks tətbiqidir. Burada — gecə enürezindən fərqli olaraq — bir müdaxilə deyil, çoxqatlı strategiya tələb olunur:

1. Birinci hissədə müxtəlif məktəblərdən texnikalar ardıcıl şəkildə istifadə olunur (KDT, sxem-terapiya, ACT-dan kognitiv defüsion, dini-mənəvi mühakimə)
2. İkinci hissədə dinamik yanaşmanın praktik komponenti strukturlaşdırılmış 4 etap formasında təqdim olunur

Pasiyent üçün vacib olan «psixoloji məsləhət» çərçivəsində deyil, strukturlaşdırılmış, ölçülə bilən, ardıcıl klinik metoddur — eyni gecə enurezi protokolunda olduğu kimi.

Aşağıdakı fəsildə dünya psixoterapevtik akkreditasiyasının sistemi, beynəlxalq tələblər və Azərbaycandakı vəziyyət təqdim olunur — yəni keyfiyyətli psixoterapiya xidmətinin institusional çərçivəsi.

AKKREDİTASİYA VƏ KEYFİYYƏT NƏZARƏTİ: BEYNƏLXALQ STANDARTLAR VƏ AZƏRBAYCANDA VƏZİYYƏT

Niyə akkreditasiya vacibdir?

Psixoterapiya — pasiyentin psixi vəziyyətinə dərin müdaxilə edən fəaliyyətdir. Yanlış aparılan terapiya nəinki effektsiz olur, həm də pasiyentə aktiv ziyan vura bilər: «psixoloji məsləhət» çərçivəsində, müştəri-terapevt sərhədlərinin pozulması, «psixoloji məsləhət» çərçivəsində, klinik qiymətləndirmə qabiliyyəti olmayan mütəxəssisin ağır psixiatrik halları «psixoloji məsləhət» çərçivəsində qəbul etməsi — bütün bunlar pasiyentin vəziyyətini ağırlaşdıra bilər və bəzi hallarda fəlakət nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Bu səbəbdən bütün dünyada psixoterapevtik fəaliyyət üzərində sərt, çoxsəviyyəli akkreditasiya sistemləri mövcuddur. Hər psixoterapevtik məktəb öz tələblərini formalaşdırmışdır və bu tələblər müzakirə edilməyən minimum standartdır: ya yerinə yetirilir, ya da yerinə yetirilmir; üçüncü variant mövcud deyil.

Bu fəsildə dünyanın aparıcı psixoterapevtik məktəblərinin akkreditasiya tələbləri konkret rəqəmlərlə təqdim olunur, sonra Azərbaycandakı vəziyyət obyektiv qiymətləndirilir.

Beynəlxalq akkreditasiya orqanları və tələbləri

Psixoanaliz: International Psychoanalytical Association (IPA)

IPA — 1910-cu ildə Sigmund Freud tərəfindən təsis edilmiş, dünyanın əsas akkreditasiya və tənzimləyici qurumudur. 12 000 psixoanalitik üzv və 70 təşkilat ona daxildir. IPA özünün missiya bəyanatında belə müəyyənləşir: *«Dünyada psixoanalitik peşənin əsas akkreditasiya edən və tənzimləyici qurumu.»*

IPA üzvlüyünə qəbul olunmaq üçün tələblər (Eitingon modeli — ən geniş yayılmış model):

Cədvəl 10. IPA-nın psixoanalitik təlim tələbləri

Komponent	Minimum tələb
Şəxsi analiz	IPA-nın psixoanalitik təlim üçün tələbləri, tanınmış təlim analitiki ilə
Klinik təcrübə (psixiatrik)	Psixiatriya bölməsində 140 saat, konsultant-psixiatrın supervizyası altında
Müşahidə təlimi (uşaq müşahidəsi)	12 ay, həftədə bir dəfə, qrup seminarları ilə birlikdə
Nəzəri seminarlar	Həftədə 21 saat (3 saat seminar, 12 saat klinik iş, 3 saat hesabat hazırlanması, 3 saat fərdi öyrənmə), 36 həftə ərzində
Müşayiət olunan klinik hallar	Tam təlim analizi hallarının superviziyası altında, bir neçə il
Ümumi müddət	Minimum 4 il nəzəri təlim, təcrübədə 7–10 il

Mənbə: IPA-nın Prosessual Məcəlləsi (ing. IPA Procedural Code), 2024-cü il redaksiyası; Britaniya Psixoanalitik Assosiasiyası (ing. British Psychoanalytic Association) — IPA-nın tərkib cəmiyyəti, təlim tələbləri (ing. training requirements), 2024.

Bu tələblər çoxşəbəkəli verifikasiya sistemi ilə təmin olunur: təlim institutu IPA komponent cəmiyyəti olmalı, supervizor IPA-da qeydiyyatdan keçmiş olmalı, hər namizəd Beynəlxalq Psixoanalitik Tədqiqatlar Təşkilatının (ing. IPSO) qeydiyyatına alınmalıdır. Adi sertifikatlaşma kursları — hətta tanınmış psixoanalitiklər tərəfindən aparılsa da — IPA üzvlüyünü əvəz etmir.

Kognitiv-davranış terapiyası: Avropa Davranış və Kognitiv Terapiyalar Assosiasiyası (ing. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT)

EABCT — 1976-cı ildə qurulmuş Avropa təşkilatıdır, hazırda 43 ölkədən 56 milli assosiasiyanı birləşdirir. EABCT öz növbəsində milli assosiasiyaları akkreditə edir, milli assosiasiyalar isə fərdi mütəxəssisləri.

Bu sistem — iki səviyyəli akkreditasiya zənciri:

- EABCT konkret ölkənin milli assosiasiyasını akkreditə edir (akkreditasiya edilmiş milli assosiasiyalar siyahısı eabct.eu saytında açıq elan edilir)
- Akkreditasiya edilmiş milli birlik fərdi KDT-terapevtlərini akkreditasiya edir

EABCT-nin akkreditasiya tələbləri:

- Milli assosiasiya EABCT-nin tam üzvü olmalıdır
- Müəyyən akkreditasiya sxemini həyata keçirməlidir
- Müəyyən edilmiş təlim standartlarına cavab verməlidir
- Davamlı peşə inkişafı (ing. CPD — Continuing Professional Development) sistemi mövcud olmalıdır

Cədvəl 11. EABCT-də Azərbaycan və regionun vəziyyəti

Ölkə	**Akkreditə edilmiş milli assosiasiya**	**Akkreditasiya tarixi**
Türkiyə	TACBT — Türk Kognitiv-Davranış Terapiyaları Dərnəyi (türk. Türk Bilişsel-Davranış Terapileri Derneği)	2013-cü il, mart
Türkiyə	ACBP — Türk Bilişsel Davranış Psikoterapileri Derneği	2016 mart
Ukrayna	UACBT — Ukrayna KDT Assosiasiyası	2013 sentyabr
Gürcüstan	GACBT — Gürcü KDT Assosiasiyası	2020 fevral
Estoniya	EKKA — Estoniya KDT Assosiasiyası	2024 mart
Azərbaycan	**— (yoxdur)**	**—**

Mənbə: EABCT-in akkreditasiya edilmiş birliklər siyahısı (ing. EABCT Accredited Associations List), eabct.eu, 2025-ci il, aprel.

Bu cədvəl mühüm faktı göstərir: Azərbaycanın bütün qonşu ölkələrində və regionda — Türkiyədə, Gürcüstanda, Ukraynada — EABCT tərəfindən akkreditə edilmiş milli KDT assosiasiyaları mövcuddur. Azərbaycanın isə yoxdur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda fərdi KDT-terapevtlərin EABCT akkreditasiyasını ala bilməsi üçün yeganə yol başqa ölkənin (məsələn, Türkiyə və ya Gürcüstan) akkreditə edilmiş assosiasiyası vasitəsilədir.

Dialektik davranış terapiyası: DBT-Linehan Board of Certification (DBT-LBC)

DBT-LBC — 501(c)(3) statuslu qeyri-kommersiya təşkilatıdır, DBT-nin yaradıcısı Dr. Marsha Linehan tərəfindən şəxsən təsdiqlənmiş yeganə sertifikatlaşma orqanıdır. Bu mühüm məqamdır: bir çox təşkilat «DBT sertifikatı» verir, lakin yalnız DBT-LBC sertifikatlaşdırması modelin yaradıcısı tərəfindən tanınmışdır.

Cədvəl 12. DBT-LBC sertifikatlaşma tələbləri

Komponent	**Minimum tələb**
Lisenziya	Müstəqil lisenziyalı klinik mütəxəssis (psixoloq, psixiatr və ya sosial işçi)
Akademik təhsil	Magistr dərəcəsi və ya yuxarı (psixi sağlamlıq sahəsində)
DBT-yə xüsusi didaktik təlim	Minimum 40 saat akademik təlim
Klinik təcrübə	Minimum 12 ay aktiv DBT praktikası
DBT komandası	**Aktiv DBT konsultasiya komandası üzvlüyü tələb olunur** («Linehanın göstərişi: mütəxəssis DBT komandasında deyilsə, o, DBT tətbiq etmir»)
Klinik hallar	Azərbaycanla həmsərhəd olan Türkiyə, Gürcüstan və Ukraynada
Yazılı imtahan	Bütün məcburi materiallar Azərbaycanla həmsərhəd olan Türkiyədə, Gürcüstanda və Ukraynada

Komponent	Minimum tələb
Video sessiyalar	3 ardıcıl sessiya videosunun təhlili, müəyyən edilmiş sadiqlik kodlaşdırması standartlarına uyğunluq meyarları ilə
Tövsiyə məktubu	Komanda lideri və ya lisenziyalı DBT mütəxəssisindən
şüurlu diqqət təlimi	Rəsmi şüurlu diqqət təlimi

Mənbə: DBT-LBC.org, Individual Certification Requirements, 2024.

Bu tələblərin sərtliyi DBT-nin xüsusiyyəti ilə bağlıdır: bu metod xroniki intihar (suisid) riski olan, sərhəd şəxsiyyət pozuntusu olan pasientlər üçün hazırlanmışdır. Burada modelə dəqiqliklə əməl etmə (ing. model fidelity) həyati əhəmiyyət daşıyır — yetersiz hazırlıqlı mütəxəssisin «DBT» adı altında edə biləcəyi səhvlər pasientin həyatı üçün təhlükəlidir.

EMDR: EMDR Europe

EMDR Europe — 41 ölkədən 37 000 üzvü olan Avropa təşkilatıdır. EMDR-də üç səviyyəli akkreditasiya sistemi mövcuddur:

Cədvəl 13. EMDR Europe akkreditasiya səviyyələri

Səviyyə	Tələblər
Practitioner (Praktik mütəxəssis)	Klinik təhsil + EMDR Europe akkreditə edilmiş trener tərəfindən təlim (1-ci və 2-ci səviyyə təlimi, ümumilikdə təxminən 50 saat) + supervizyalı praktika (10 saat supervizyada, minimum 50 EMDR sessiyası ilə)
Consultant (Konsultant/Supervizor)	Practitioner statusu + əlavə təlim + 3 il aktiv EMDR praktikası + müştərilərlə 50 saat superviziya aparılması
Trainer (Təlimçi)	Consultant statusu + EMDR Europe Təlimçi Akkreditasiyası Komitəsi (ing. EMDR Europe Trainer Accreditation Committee) tərəfindən qiymətləndirmə

Mənbə: EMDR Europe Accreditation Committee, 2024.

Göz hərəkətləri vasitəsilə desensibilizasiya və yenidən emal (EMDR) üzrə Avropa assosiasiyasının (ing. EMDR Europe) Azərbaycandakı vəziyyəti: Azərbaycan bu təşkilatın akkreditə edilmiş milli assosiasiyalar siyahısında deyil. Eyni şəkildə Azərbaycanda fərdi EMDR akkreditasiyasını əldə etmək üçün yeganə yol qonşu ölkədəki (məsələn, Türkiyədəki) akkreditə edilmiş təşkilat vasitəsilədir.

Avropa İttifaqında ümumi tənzimləmə vəziyyəti

Avropa Davranış və Koqnitiv Terapiyalar Assosiasiyasının (EABCT) rəsmi mövqeyi vacib bir məqamı vurğulayır: «Avropa səviyyəsində *psixoloji terapiyaların təcrübəsini tənzimləyən qanunvericilik mövcud deyil. Hazırda Avropa İttifaqında psixoterapiyanı tənzimləyən və ya nəzarət edən rəsmi Avropa orqanı yoxdur. Bu tənzimləmə yoxluğu EABCT-nin əsas narahatlıq mənbələrindən biridir.»*

Bu o deməkdir ki, hətta Avropa İttifaqı çərçivəsində belə psixoterapiya peşə tənzimlənməsi milli səviyyədə həyata keçirilir. Bəzi ölkələrdə (Almaniya, Hollandiya, Avstriya) güclü dövlət lisenziyalaşma sistemi mövcuddur. Digər ölkələrdə isə bu sistem daha zəifdir. Bu şəraitdə peşə standartlarının yeganə təminatçısı beynəlxalq peşəkar akkreditasiya orqanlarıdır: Beynəlxalq Psixoanalitik Assosiasiya (IPA), Avropa Davranış və Koqnitiv Terapiyalar Assosiasiyası (EABCT), Dialektik Davranış Terapiyası üzrə Sertifikatlaşdırma və Akkreditasiya Şurası (DBT-LBC), EMDR Europe.

Azərbaycandakı vəziyyət

Vəziyyət obyektiv qiymətləndirmə tələb edir.

<Heading 4> Dövlət tənzimlənməsi

Azərbaycan Respublikasında psixoterapevtik fəaliyyət üzrə xüsusi dövlət lisenziyalaşma sistemi mövcud deyil. Tibb sahəsi üzrə dövlət lisenziyalaşması psixiatriyanı əhatə edir, lakin psixoterapiya və psixoloji məsləhət sahələri ayrıca tənzimlənmir. Bu o deməkdir ki, qanunvericilik baxımından ixtisaslaşdırılmış psixoterapevtik hazırlığı olmayan psixoloq da, lisenziyalı klinik psixiatr da eyni hüquqi statusda «psixoterapevt» kimi xidmət göstərə bilir. Bu boşluq peşə akkreditasiyasına ehtiyacı Azərbaycan şəraitində daha da artırır.

Beynəlxalq akkreditasiya statusu:

Yuxarıda göstərilən beynəlxalq orqanların heç birində — IPA, EABCT, DBT-LBC, EMDR Europe — heç birində Azərbaycanın akkreditə edilmiş milli

assosiasiyası yoxdur. Bu, obyektiv faktdır və açıq mənbələrdə (eabct.eu, ipa.world, dbt-lbc.org, emdr-europe.org) yoxlanıla bilər.

Beynəlxalq psixiatrik strukturlar üzrə vəziyyət:

Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə verifikasiya olunmuş yeganə peşə təşkilatı — Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasıdır (AZPA; psychiatry.az). AZPA Ümumdünya Psixiatriya Assosiasiyasının (ing. World Psychiatric Association) tamhüquqlu üzvüdür. Bu, beynəlxalq səhiyyə icmasında AZPA-nın qanuniliyini birmənalı təsdiqləyir.

WPA — wpanet.org məlumatına görə 145-dən çox milli psixiatriya assosiasiyalarını birləşdirən beynəlxalq təşkilat — sərt üzvlük tələblərinə malikdir: milli cəmiyyət rəsmi statusda olmalı, açıq peşə standartlarına uyğun olmalı, dövri hesabatlar verməlidir. AZPA bu tələbləri yerinə yetirir.

Digər təşkilatların statusu:

Azərbaycanda psixologiya və psixoterapiya sahəsində fəaliyyət göstərən bir sıra qeyri-kommersiya təşkilatları mövcuddur. Onlardan bəziləri öz veb-saytlarında «beynəlxalq əməkdaşlıq», «dünya konqresləri», «beynəlxalq akkreditasiya» kimi ifadələrdən istifadə edir. Bu iddiaların beynəlxalq mənbələr vasitəsilə yoxlanılması bir çox hallarda müsbət nəticə vermir.

Bu səbəbdən fəsildə həmin təşkilatların adları çəkilmir — məqsəd mübahisə deyil, klinik praktika üçün etibarlı çərçivəni göstərməkdir. Hər hansı təşkilatın legitimliyini öyrənmək istəyən mütəxəssis və ya pasiyent aşağıdakı obyektiv mənbələri yoxlaya bilər:

1. eabct.eu/training-and-accreditation/accredited-association/ — Koqnitiv Davranış Terapiyası (KDT) üzrə akkreditasiya
2. ipa.world — psixoanalitik akkreditasiya üzrə rəsmi məlumat mənbəyi
3. dbt-lbc.org — Dialektik Davranış Terapiyası üzrə Sertifikatlaşdırma və Akkreditasiya Şurası (DBT-LBC)
4. emdr-europe.org — EMDR akkreditasiyası
5. wpanet.org — Ümumdünya Psixiatriya Assosiasiyasının (WPA) rəsmi saytı

Mütəxəssisi necə fərqləndirmək olar?

Pasiyent və ya gənc mütəxəssis «beynəlxalq sertifikat» iddiası ilə qarşılaşdıqda aşağıdakı suallar mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

1. Sertifikat hansı orqan tərəfindən verilmişdir?

Yoxlamanın ilk addımı — sertifikatı verən təşkilatın yuxarıda sadalanan beynəlxalq orqanların biri ilə rəsmi əlaqədə olub-olmadığını yoxlamaqdır. *«Beynəlxalq sertifikat»* ifadəsi özü-özlüyündə heç bir məna ifadə etmir; vacib olan hansı beynəlxalq orqanın sertifikatı olduğudur.

2. Təlim nə qədər davam edib?

Yuxarıda göstərilən məlumatlara baxın. Bir həftəlik və ya bir aylıq «beynəlxalq sertifikat» — heç bir tanınmış akkreditasiya tələblərinə cavab vermir. Beynəlxalq Psixoanalitik Assosiasiyaya (IPA) üzvlük ən azı 4 il, EABCT fərdi akkreditasiyası 3–4 il, DBT-LBC sertifikatı 12 ay fasiləsiz təcrübə tələb edir — bunlar şübhə doğurmayan ən qısa müddətlərdir.

3. Superviziýa nəzərdə tutulur mu?

Bütün ciddi akkreditasiya sistemlərində superviziýa əsas yer tutur. Sertifikat sahibinin neçə saat superviziýalı klinik iş gördüyü öyrənilməlidir. Supervizyalı iş olmadan verilmiş sertifikat — akademik sertifikat olur (kursun başa çatdırılması kimi), klinik səlahiyyət sertifikatı deyil.

4. Davamlı peşə inkişafı (ing. continuing professional development, CPD) tələb olunur mu?

Akkreditasiyalar müəyyən müddətdən sonra təzələnməlidir. EABCT 5 ildə bir, DBT-LBC 4 ildə bir, EMDR Europe isə 5 ildə bir təzələmə tələb edir. «Bir dəfə alınmış ömürlük sertifikat» — ciddi peşə standartlarının olmamağının əlamətidir.

5. Yerli psixi sağlamlıq təşkilatları — beynəlxalq tanınmanın sübutu ola bilər mi?

Yerli psixoloq və ya psixoterapevt klubuna, assosiasiyasına üzvlük — bu özü-özlüyündə beynəlxalq tanınma deyil. Bu cür təşkilatın özü beynəlxalq akkreditə edilmiş orqana üzvdür mü? Bu əsas sualdır.

Kitabın bu şəraitdəki yeri

Bu kitab beynəlxalq akkreditasiyanın əvəzi deyil — akkreditasiyaya hazırlıq vasitəsi kimi nəzərdə tutulmuşdur. O, mütəxəssisə klinik diaqnostika, sübuta əsaslanan müdaxilələr, strukturlaşdırılmış protokollar və klinik düşüncə üçün etibarlı çərçivə təqdim edir.

Mütəxəssis bu kitabdakı protokollar və müzakirə əsasında öz təcrübəsini formalaşdırdıqdan sonra rəsmi peşə hazırlığı (Türkiyə, Gürcüstan, Almaniya və ya digər ölkələrdə akkreditə edilmiş təşkilatlar vasitəsilə) üçün möhkəm əsas əldə etmiş olur. Həmçinin bu kitab pasiyentlər üçün — onların aldıqları yardımın keyfiyyətini

qiymətləndirmək, düzgün sualları vermək, sübuta əsaslanan müalicə tələb etmək üçün ilkin istiqamətverici rol oynaya bilər.

Növbəti bölmə — bu Müqəddimənin yekun fəsli — bu kitabın həqiqətən niyə indi və niyə Azərbaycanda zəruri olduğunu aydın şəkildə əsaslandırır.

6A00–6A0Z NEYROİNKİŞAF POZUNTULARI

Neyroinkişaf pozuntuları (Neurodevelopmental disorders)

XBT-11 **6A00**	**6A00 İNTELLEKTUAL İNKİŞAF POZUNTUSU** **6A00 İNTELLEKTUAL İNKİŞAF POZUNTULARI (ing. Disorders of intellectual development)**
XBT-10 F70–F79	Əqli gerilik
DSM-5-TR F70–F73	İntellektual inkişaf pozuntusu (ing. intellectual developmental disorder)

1. Tərif və nozologiya

İntellektual inkişaf pozuntusu (XBT-11: 6A00 — ing. Disorder of Intellectual Development; DSM-5-TR: F70–F73 — əvvəlki «əqli gerilik») — inkişaf dövründə (DSM-5-TR-ə görə 18, AAIDD-yə görə 22 yaşa qədər) başlayan, həm intellektual funksiyalarda (orta səviyyədən təxminən 2 standart kənaraçıxma və ya daha çox aşağı, standartlaşdırılmış testlərdə qiymət təxminən 70-dən az), həm də adaptiv davranışda (konseptual, sosial, praktik sahə) əhəmiyyətli məhdudiyyətlərlə səciyyələnən neyroinkişaf pozuntusudur.

«Mental retardation» termini 2010-cu ildən beynəlxalq elmi cəmiyyət tərəfindən damğalama (ing. stigma) və dəqiqsizlik səbəbilə tərk edilmişdir (ABŞ-da 2010-cu ildə qəbul edilmiş «Rosa qanunu» federal səviyyədə dəyişikliyi təmin etmişdir).

2. Tarixçə

- Esquirol (1838) «idiotiya» (fr. idiotie) termini ilə anadangəlmə intellektual məhdudiyyəti demensiya (qazanılmış pozulma) ilə fərqləndirmişdir.
- Binet və Simon (1905) ilk standartlaşdırılmış intellekt şkalasını yaratmış, bununla intellekt əmsalı (IQ) konsepsiyasının əsası qoyulmuşdur (Stern 1912).

- AAMR/AAIDD (1959, 1973, 1992, 2002, 2010, 2021): tərifin təkamülü — yalnız IQ-dan adaptiv davranış + dəstək tələbi modelinə keçid. AAIDD-nin 12-ci nəşri (2021) intellektual funksiyanı, adaptiv davranışı, inkişaf dövründə başlanmanı və fərdi dəstək tələblərinin qiymətləndirilməsini əhatə edir.
- DSM-IV-də (1994) «əqli gerilik» termini DSM-5-də (2013) «intellektual inkişaf pozuntusu» ilə əvəz edilmişdir. Şiddətin müəyyən edilməsi üçün əsas IQ-dan adaptiv funksiyaya keçirilmişdir.
- XBT-11 (2019-cu ildə qəbul edilmiş, 2022-ci ildə qüvvəyə minmiş) «intellektual inkişaf pozuntuları» — XBT-10-dakı «Mental Retardation» (F70–F79) qrupu yenidən adlandırılmış, klinik və adaptiv ölçütlər birlikdə vurğulanmışdır.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: ümumi əhalidə təxminən 1% (Maulik P.K. və b. Res Dev Disabil 2011 meta-analiz, 52 tədqiqat); aşağı və orta gəlirli ölkələrdə nisbət daha yüksəkdir.
- Şiddət bölgüsü: təxminən 85% yüngül, təxminən 10% orta, təxminən 3,5% ağır, təxminən 1,5% dərin.
- Cins: kişilərdə daha sıx (1,2–1,9: 1), X xromosomu ilə əlaqəli genetik səbəblərlə (məsələn, Frajil X sindromu) əlaqəlidir.
- Birgə xəstəliklər: epilepsiya 20–30%, motor pozuntular 20–40%, görmə/eşitmə pozuntuları 10–25%; psixi birgə xəstəliklər əhali (populyasiya) göstəricisindən 3–4 dəfə yüksəkdir (ASP, DDHP, narahatlıq, davranış pozuntuları).
- Ölüm göstəricisi: ağır və dərin formalarda gözlənilən ömür qısalır əsas səbəblər aspirasiya pnevmoniyaları, epileptik status və ürək-damar anomaliyalarıdır.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik səbəblər (halların 50–60%-i müəyyən edilə bilər)

- Xromosom anomaliyaları: Daun sindromu (trisomiya 21) — ən sıx genetik səbəb, təxminən 1/700 doğum; Edvards sindromu (T18), Patau sindromu (T13), 22q11.2 delesiyası (DiGeorge sindromu), Vilyams sindromu (7q11.23), Prader-Villi və Anqelman sindromları (15q11-q13), Cri-du-chat sindromu (5p-).

- X-bağlı: Fragile X sindromu (FMR1 geni, CGG təkrarları) — irsi keçən ən sıx forma, təxminən 1/4000 oğlanda; Rett sindromu (MECP2, demək olar həmişə qızlarda).
- Təkgenli pozuntular: tuberoz skleroz (TSC1/TSC2), neyrofibromatoz (NF1), fenilketonuriya (PAH — müalicə oluna bilən), Wilson xəstəliyi.
- Nüsxə sayı dəyişiklikləri (NSD; copy number variants, CNV): mikroçip analizi ilə aşkar olunur — naməlum etiologiyalı hallarda 10–20%.

4.2 Prenatal qeyri-genetik səbəblər

- İnfeksiyalar: TORCH (toksoplazmoz, məxmərək, sitomeqalovirus, herpes), Zika, sifilis.
- Toksik: fetal alkoqol spektri pozuntuları (FASD — qarşısı alına bilən səbəb), hamiləlikdə valproat, izotretinoin, kokain, qurğuşun.
- Metabolik və endokrin: anada müalicəsiz hipotireoz, ağır diabet, fenilketonuriya.
- İşemik və hipoksik: plasenta çatışmazlığı, intrauterin inkişaf geriliyi.

4.3 Perinatal səbəblər

- Ağır vaxtından əvvəl doğulma (<32 həftə), aşağı doğum çəkisi (<1500 q).
- Doğuş asfiksiyası, hipoksik-işemik ensefalopatiya.
- Yenidoğulmuşlarda kernikterus (müalicə oluna bilən — fototerapiya).
- Yenidoğulmuşlarda sepsis və menenjit.

4.4 Postnatal səbəblər

- Bakterial menenjit (xüsusilə pnevmokok, meningokok), viral ensefalit.
- Travmatik beyin zədələnməsi (TBZ) — uşaqlıq dövründə.
- Qurğuşun zəhərlənməsi — qarşısı alına bilən səbəb (ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika (qarşısının alınması) Mərkəzinin (CDC) qanda qurğuşunun istinad dəyəri 2021-ci ildən 3,5 μq/dL, əvvəllər 5 μq/dL idi; uşaqlarda təhlükəsiz qurğuşun səviyyəsi müəyyən edilməmişdir).
- Ağır yod çatışmazlığı (endemik kretinizm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) profilaktika proqramları ilə demək olar ki, tamamilə aradan qaldırılmışdır).
- Sosial-ekoloji deprivasiya — həddindən artıq ağır psixoloji qayğısızlıq inkişafa təsir edə bilər (Rumıniya yetimxana tədqiqatları, Nelson C.A. və b. Science 2007).

5. Klinik təzahürlər

Şiddət bölgüsü (DSM-5-TR / XBT-11 — adaptiv funksiya əsaslı)

Yüngül (mild) — IQ təxminən 50–70, adaptiv çatışmazlıq yüngül

Akademik gecikmə məktəbə qədər nəzərə çarpmaya bilər. Oxuma, riyaziyyat, mücərrəd təfəkkür çətindir. Sosial naivlik, asanlıqla aldadıla bilir. Praktik bacarıqlar (özünə baxım, ev işləri) tamamlanır. Müstəqil yaşayış dəstəklə mümkündür, dəstəkli iş üçün uyğundur.

Orta (moderate) — IQ təxminən 35–49

Erkən uşaqlıqda gecikmə görünür. Sadə nitq, konkret düşüncə. Özünə baxım təlim ilə əldə olunur. Strukturlaşdırılmış sosial-iş şəraitində fəaliyyət göstərir. Nəzarətli yaşayış (qrup evi, ailə) tipikdir.

Ağır (severe) — IQ təxminən 20–34

Çox az nitq, sadə tələblər başa düşür. Özünə baxımda davamlı kömək. Tibbi və davranışla bağlı birgə xəstəliklər sıxdır.

Dərin (profound) — IQ < 20

Çox az və ya heç nitqi olmayan, sensor-motor səviyyəli ünsiyyət. Tam baxım tələb olunur. Motor, görmə və eşitmə ilə əlaqəli pozuntular çox sıxdır.

İnkişaf trayektoriyası: erkən motor və nitq gecikmələri (oturma, ayaq üstə durma, ilk sözlər) müşahidə olunur; məktəb yaşında akademik məhdudiyyət önə çıxır; yetkinlikdə adaptiv tələblərin artması ilə fərq daha aydın olur.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11, AAIDD 12e konsensus nöqtələri)

A. İntellektual funksiyada əhəmiyyətli məhdudiyyət — standartlaşdırılmış, mədəni və kontekstə uyğunlaşdırılmış intellekt testində orta səviyyədən təxminən 2 standart kənaraçıxma aşağı nəticə (qiymət təxminən 70 və ya daha az, ölçmə xətasının ±5 bal nəzərə alınması ilə).

B. Adaptiv davranışda əhəmiyyətli məhdudiyyət — aşağıdakı üç sahə ən azı birində 2 SD aşağı nəticə:

- Konseptual (dil, oxuma, yazı, riyaziyyat, yaddaş, problemin həlli);
- Sosial (şəxslərarası bacarıqlar, sosial məsuliyyət, sadəlövhlük məsələləri);
- Praktik (özünə baxım, iş, sağlamlıq, təhlükəsizlik).

C. Başlanğıc inkişaf dövründə — simptomlar uşaqlıq və yeniyetməlikdə nəzərə çarpır (yetkinlik yaşına qədər).

D. İstisnalar — sensor (görmə, eşitmə) pozuntusu, motor pozuntu, dil mənşəyi, mədəni-dil maneə və ya psixiatrik pozuntu ilə tam izah edilmir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR (317, 318.0–318.2 / F70–F73): şiddət adaptiv funksiyaya görə təyin olunur, IQ standartlaşdırılmış testlə təsdiqlənir, şiddət isə adaptiv funksiyaya görə müəyyən edilir. Başlanğıc «inkişaf dövründə» (18 yaşa qədər nəzərdə tutulur, lakin AAIDD-nin 22 yaş tərifi qəbul edilə bilər).
- XBT-11 (6A00): yüngül, orta, ağır, dərin (eyni terminologiya); şiddət adaptiv davranışa görə müəyyən edilir, IQ isə diaqnostik meyar kimi ayrıca qiymətləndirilir; əlavə kvalifikatorlar — etiologiya (genetik, prenatal, perinatal, postnatal, naməlum) və komorbidliklər.
- AAIDD 12e (Schalock R.L. və b. 2021): dəstək tələblərinin formal qiymətləndirilməsi (SIS — Dəstək İntensivliyi Şkalası; ing. Supports Intensity Scale) klinik formulasiyaya daxil edilir; başlanğıc yaşı 22-yə qədər (DSM-dən fərqli olaraq); intellektual funksiyanın qiymətləndirilməsi istisnaya deyil, dəstəklənən proseslərə yönəlir.
- AAP (Moeschler J.B., Shevell M.S., Pediatrics 2014, reaffirmed 2020): diaqnoz qoyulduqdan sonra etiologiya axtarışı pillə-pillə — birinci sıra: tarixçə, fiziki müayinə (dismorfik əlamətlər), xromosomal mikroarray, Fragile X, müalicə oluna bilən metabolik skrininq (PKU, biotinidaza, tiroid, qaraciyər, böyrək); seçici: beyin maqnit-rezonans tomoqrafiyası (MRT), elektroensefaloqrafiya (EEQ), tam ekzom sekvenləşdirməsi (WES).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. İnkişaf tarixçəsi (anadangəlmə, perinatal, postnatal) və ailə tarixçəsi (3 nəsil).
2. Fizikal müayinə — boy, baş çevrəsi, dismorfik əlamətlər, neyroloji, dəri müayinəsi (süd-qəhvəyi ləkələr — cafe-au-lait, hipopiqmentasiya).
3. Standartlaşdırılmış intellekt testi (WISC-V 6–16 yaş; Stanford-Binet 5 — 2 yaşdan yuxarı; Bayley-4 — 3,5 yaşdan aşağı).
4. Adaptiv davranışın qiymətləndirilməsi (Vineland-3, ABAS-3 — uyğunlaşma davranışı şkalası).
5. Görmə və eşitmə testləri (sensor pozuntularının istisna edilməsi).
6. Etioloji birinci sıra laboratoriya müayinələri — xromosom mikroarray analizi (CMA), Fragile X (FMR1), TSH, qurğuşun səviyyəsi, qaraciyər/böyrək, kreatinin və amin turşusu profili.
7. Seçici: beyin MRT (mikrosefaliya, fokus neyroloji əlamətlər olduqda), EEQ (epilepsiya şübhəsi), trio ekzom sekvensingi (CMA mənfi olduqda).

8. Birgə xəstəliklər üzrə ilkin yoxlama: ASP (M-CHAT-R/F, ADOS-2 — autizm skrininqi alətləri), DDHP (Conners şkalası), narahatlıq, depressiya, davranış pozuntusu.

6.4 Differensial diaqnostika

Pozuntu	Fərqləndirici əlamətlər
İnkişaf öyrənmə pozuntusu (6A03)	Akademik sahə diskret çatışmazlıq, ümumi koqnitiv səviyyə normal.
Nitq və dilin inkişaf pozuntusu (6A01)	Nitq və dil sahəsində qabaqcıl çatışmazlıq; qeyri-verbal IQ normal.
Autizm spektri pozuntusu (6A02)	Sosial ünsiyyət çatışmazlıq və məhdud təkrarlanan davranış əsas; IQ aralığı geniş.
Qlobal inkişaf gecikməsi (5 yaşdan kiçik uşaqlarda)	5 yaşa qədər müvəqqəti diaqnoz; standart IQ testləri etibarlı deyil.
Demensiya (6D80–6D8Z)	Qazanılmış pozulma — əvvəlcə normal inkişaf, sonra zəifləmə.
Sosial-ekoloji deprivasiya	Stimullaşdırıcı mühitdə intellektual funksiya bərpa oluna bilər.
Yalançı intellektual zəiflik (xroniki xəstəlik, depressiya)	Əhval və ya somatik amilin korreksiyasından sonra koqnitiv funksiya bərpa olur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Standartlaşdırılmış testlər

- İntellekt: WISC-V (6–16 yaş), Stanford-Binet 5 (2 yaşdan yuxarı), WAIS-IV (16 yaşdan yuxarı), Bayley Scales of Infant Development 4 (<3,5 yaş), Kaufman ABC-II.
- Adaptiv davranışın qiymətləndirilməsi: Vineland-3, ABAS-3, «Scales of Independent Behavior-Revised» (müstəqil davranış şkalası).
- Dəstək tələbi: SIS-A (yetkinlər), SIS-C (uşaqlar) — AAIDD.

7.2 Laborator müayinələr (AAP 2014 / 2020 protokolu)

Birinci sıra (bütün hallarda): tam qan sayı, qaraciyər və böyrək funksiyası, TSH, kreatinin, amonyak, laktat, kreatin və amin turşu profili (sidik və qan), qurğuşun səviyyəsi.

Birinci sıra genetik: xromosom mikroçip analizi (CMA — aşkarlanma dərəcəsi 15 –20%), Fragile X (FMR1) bütün oğlanlarda (yield təxminən 2%, qadınlarda təxminən 1%).

Seçici: bütün ekzomun ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi (WES — aşkarlanma dərəcəsi 25–40%, CMA mənfi olduqda), MECP2 (Rett şübhəsi qızlarda), spesifik sindromal genlər.

7.3 İnstrumental müayinələr

- Beyin MRT — fokus neyroloji əlamətlər, mikro/makrosefaliya, tutmalar, reqressiya hallarında.
- EEQ — tutma şübhəsi, reqressiya.
- Görmə və eşitmə müayinələri bütün hallarda ilkin mərhələdə aparılır.
- Ürək exokardioqrafiyası (ExoKQ) və EKG — Daun və 22q11.2 delesiyası kimi sindromlarda.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (AAIDD 12e, AAP 2014, NICE NG54, ÜST mhGAP konsensusu)

1. İntellektual inkişaf pozuntusunun «müalicəsi» yoxdur — intellektual funksiya özü-özlüyündə farmakoloji yolla bərpa olunmur. Müdaxilə fərdi dəstək, təhsil, davranış və komorbid simptomların idarə edilməsinə yönəlir.
2. Etiologiya identifikasiyası: müalicə oluna bilən səbəblərin (PKU, anadangəlmə hipotireoz, qurğuşun, biotinidaza çatışmazlığı) erkən aşkar edilməsi həlledicidir — yenidoğulmuşlar üçün ilkin yoxlama proqramlarının əsasını təşkil edir.
3. Erkən müdaxilə (0–3 yaş): bu dövrdə sübut bazası ən güclüdür (IDEA Part C ABŞ-da; bütün inkişaf etmiş ölkələrdə oxşar proqramlar). Sosial və koqnitiv nəticələri yaxşılaşdırır.
4. Fərdi təhsil planı (FTP): məktəbdə akademik və adaptiv hədəflər; AAIDD-nin dəstək tələblərinə əsaslanan yanaşma tətbiq edilir.
5. Davranış müdaxilələri: Tətbiqi davranış analizi (ing. Applied Behavior Analysis; ABA — TDA) və pozitiv davranış dəstəyi (PBS) — problematik davranışların azaldılmasında və yeni bacarıqların inkişafında effektivdir.

6. Ailə dəstəyi: psixoedukasiya, müvəqqəti istirahət dəstəyi (ing. respite care), həmyaşıd dəstəyi qrupları, sosial xidmət koordinasiyası.
7. Komorbidlik müalicəsi: epilepsiya (standart antiepileptik), DDHP (stimulyantlar; Cortese 2018 şəbəkə meta-analizi uşaqlarda metilfenidatı birinci seçim göstərir, lakin komorbid pozuntulu tədqiqatları kənarlaşdırmışdır — İD fonunda sübut bazası ayrıdır və daha məhduddur), seçici serotonin geri alım inhibitorları (SSGİ) aşağı dozada başlanılır, aqressiya (davranış müdaxiləsi birinci sıra seçimdir; risperidon və ya aripiprazol yalnız ağır hallarda — FDA təsdiqi ASP-da qıcıqlanma üçün: risperidon 5–16 yaş, aripiprazol 6–17 yaş; İD üçün rəsmi təsdiq yox, sübut bazası məhdud).
8. Tibbi nəzarət: Daun sindromunda — qalxanabənzər vəz (tiroid vəzi), ürək, eşitmə, atlanto-aksial qeyri-sabitlik (ing. AAP Health Supervision for Children with Daun Syndrome 2022).
9. Yetkinlikdə keçid: dəstəkli iş (IPS modeli), müstəqil yaşayış variantları, sosial-tibbi xidmət koordinasiyası.

8.2 Müalicə metodları

1. Tətbiqi Davranış Analizi (TDA / ABA — ing. Applied Behavior Analysis) — Davranışın funksional analizi əsasında konkret hədəf-davranışların formalaşdırılması və azaldılması; sələf şərt – davranış – nəticə (ABC — Antecedent-Behavior-Consequence) çərçivəsi, diskret cəhdlər təlimi (ing. DTT — Discrete Trial Teaching), naturalistik davranış müdaxilələri. Nəticə: orta–yüksək effekt ölçüsü adaptiv bacarıqların əldə edilməsində və çətin davranışın azaldılmasında, xüsusilə autizm və İD komorbid hallarda (Eldevik S. və b. J Clin Child Adolesc Psychol 2009 meta-analiz). Bütün mərhələlərdə ev, məktəb və icma mühitinə uyğunlaşdırıla bilər.
2. Erkən Müdaxilə (ing. Early Intervention, 0–3 yaş) — Multidissiplinar (inkişaf, fizioterapiya, məşğuliyyət və nitq terapiyaları, həmçinin ailə təlimi) ev və ya mərkəz əsaslı proqramlar. Sübut: Carolina Abecedarian Project (Ramey C.T., Campbell F.A. — 30+ illik izləmə) aztəminatlı uşaqlarda IQ artımı, akademik və məşğulluq nəticələrini yaxşılaşdırmışdır. IDEA Part C.
3. Fərdi Təhsil Planı (ing. FTP / IEP — Individualized Education Program) — Akademik və adaptiv hədəflər, dəstək tədbirləri, qiymətləndirmə intervallarını sənədləşdirən hüquqi sənəd. ABŞ-da IDEA əsasında məcburidir; oxşar çərçivələr digər ölkələrdə də tətbiq olunur (Böyük Britaniya — fərdi sağlamlıq və qayğı planı, EHCP).
4. Pozitiv Davranış Dəstəyi (ing. PDD / PBS — Positive Behavior Support) — Çətin davranışların funksional analizi və davranışın əvəzlənməsi (eyni funksiyalı uyğun davranış öyrətmək). Cəzalandırma deyil, mühitin

dəyişdirilməsi və yeni bacarıqların öyrədilməsi əsas götürülür. NICE NG11 (2015) çətin davranışın idarə edilməsində birinci sıra müdaxilə kimi tövsiyə olunur.

5. Vineland Adaptiv Davranış Şkalası-3 (ing. Vineland-3 — Vineland Adaptive Behavior Scales-3) — Adaptiv davranışın istinad standartı sayılan qiymətləndirilməsi — ünsiyyət, gündəlik yaşayış, sosial və motor sahələri. Müsahibə (valideyn və ya qayğı göstərən şəxs) və müəllim formaları mövcuddur.
6. WISC-V / Stanford-Binet 5 — Standartlaşdırılmış intellekt testləri; WISC-V — 6–16 yaş, 5 əsas indeks (şifahi, vizual-məkan, mücərrəd təfəkkür, işlək yaddaş, emal sürəti); Stanford-Binet 5 — 2 yaşdan yetkinliyə.
7. Dəstək İntensivliyi Şkalası (ing. Supports Intensity Scale, AAIDD, SIS) — Dəstək tələbinin intensivliyini ölçən şkala; SIS-A yetkinlər, SIS-C 5–16 yaş üçün. Klinik planlaşdırma və xidmətlərin bölüşdürülməsi üçün istifadə olunur.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- AAIDD 12e (2021): «dəstək modeli» (supports model) — hər pozuntu dərəcəsi üçün deyil, fərdin dəstək tələbinə uyğun planlaşdırma; fasiləli (intermittent), məhdud, geniş, hərtərəfli dəstək kateqoriyaları.
- AAP 2014/2020: komorbidlik (autizm, DDHP, davranış pozuntuları) skrininq intervalları və müalicə alqoritmləri; Daun sindromu üçün ayrıca AAP 2022 protokolu.
- NICE NG54 (2016) — Mental health problems in people with learning disabilities: psixiatrik komorbidliyin diaqnostikası və müalicəsi; davranış müdaxiləsi birinci sıra; psixotrop dərmanların qeyri-spesifik istifadəsi tövsiyə edilmir — bu praktika geniş yayılsa da, yan təsir yükü və qarşılıqlı təsir riski yüksəkdir.
- WHO mhGAP Intervention Guide v2.0: aşağı və orta gəlirli ölkələrdə birinci tibbi yardım səviyyəsində qiymətləndirmə və əsas müdaxilə; ailə təlimi və icma reabilitasiyası vurğulanır.

9. Proqnoz

Yaxşı proqnoz amilləri

- Yüngül şiddət (təxminən 85% bütün İD); intellektual və adaptiv funksiyada yaxın səviyyə.
- Müalicə oluna bilən etiologiya (fenilketonuriya — PKU, anadangəlmə hipotireoz, qurğuşun zəhərlənməsi) erkən aşkarlanma

- Erkən müdaxilə (<3 yaş).
- Stabil və dəstəkləyici ailə mühiti.
- Komorbid psixiatrik və somatik vəziyyətlərin aktiv müalicəsi.
- İcma və məktəb resurslarının əlçatanlığı.

Pis proqnoz amilləri

- Dərin və ya ağır şiddət.
- Genetik sindrom kompleks fenotiplə (epilepsiya, ürək anomaliyaları, hərəki pozuntular).
- Ağır davranış pozuntuları, özü-özünə zərər.
- Ailə dəstəyinin və icma resurslarının olmaması.
- Aşkarlanmamış və müalicəsiz komorbidlik (epilepsiya, ASP, DDHP).

İzləmə hədəfləri

- Adaptiv inkişafın illik yenidən qiymətləndirilməsi.
- Tibbi nəzarət — sindrom-spesifik protokollara görə (məs. AAP Daun 2022).
- Komorbid psixiatrik vəziyyət (ASP, DDHP, narahatlıq, depressiya) skrininq.
- Davranış pozuntularının funksional analizi və müdaxiləsi.
- Yetkinlikdə dəstəkli iş və yaşayış variantları üçün keçid planlaşdırılması.
- Ailəyə müvəqqəti istirahət dəstəyi (ing. respite care) və həmyaşıd dəstəyi təklifi.

10. Mif və yanlış inamlar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «İntellektual əlillik valideynin günahıdır / cəzasıdır»

Niyə yayılmışdır: mədəni və dini-əxlaqi izahat çərçivəsi; «günahın cəzası kimi göndərilmiş övlad» obrazı; aşağı təhsilli icmalarda valideynə (xüsusilə anaya) ittiham mexanizmi.

Bioloji məntiq və sübut: İD-nin etiologiyası geniş yelpazəlidir — genetik (Daun, Fragile X), prenatal infeksiyalar, fetal alkoqol spektri pozuntusu (FASD) (yalnız valideyn müdaxiləsi ilə tam qarşısı alına bilən yeganə səbəb), perinatal asfiksiya, postnatal travma və ya menenjit. AAIDD, WHO, APA mövqeyi — İD biotibbi və/və ya inkişaf yönümlü etioloji pozuntudur, mənəvi qiymətləndirmə predmeti deyil.

Real klinik addım: etiologiya axtarışı (genetik məsləhətləşmə, sindromik və metabolik skrininq) — ittihamı təkrar hamiləlik üçün dəqiq risk hesablanmasına çevirir.

Mif 2: «Peyvəndlər (xüsusilə qızılca-parotit-məxmərək — MMR) İD-yə səbəb olur»

Niyə yayılıb: Wakefield A.J. Lancet 1998 — sonradan saxtakarlıq səbəbi ilə geri çəkilmiş tədqiqat, autizmi MMR ilə bağlamağa çalışmışdı (İD-ni yox, lakin kütləvi inamda hər iki şərt qarışdırılır).

Sübut: Taylor L.E., Swerdfeger A.L. və b. Vaccine 2014 meta-analiz n > 1,2 milyon uşaq — peyvənd ilə autizm və ya İD arasında əlaqə yoxdur. CDC, WHO, NICE mövqeyi eynidir. Daun sindromu 21-ci xromosomun meyoz zamanı ayrılmamasından (ing. nondisjunction, əksərən ana meyoz I-də) yaranır — mexanizminə görə peyvəndlə əlaqəli ola bilməz.

Mif 3: «Hamiləlikdə stress və ya yanlış düşüncələr İD-yə səbəb olur»

Sübut: psixoloji stress prenatal dövrdə neyroinkişaf üçün nisbətən zəif risk amili ola bilər, lakin İD-yə birbaşa səbəb kimi göstərilmir. Müəyyən edilmiş prenatal risklər — alkoqol (fetal alkoqol sindromu — FAS; qarşısı alına bilən ən mühüm səbəb), valproat, infeksiyalar (TORCH), qida çatışmazlığı (yod, folat). Stressin azaldılması ümumi sağlamlıq üçün faydalıdır, lakin «doğru düşüncələr» deyil, konkret profilaktik tibbi tədbirlər (peyvəndləmə, alkoholdan imtina, perinatal qayğı) effektivdir.

10.2 Zərərli «müalicə» üsulları

Mif 4: «Xelatlaşdırma terapiyası ağır metalları çıxararaq İD-ni sağaldır»

Niyə yayılıb: «ağır metallar» konsepsiyasının kütləvi mediada genişlənməsi; alternativ tibb mərkəzlərinin marketinqi.

Sübut və risk: AAP 2010 və FDA xəbərdarlığı: 2005-ci ildə xelasiya proseduru zamanı 5 yaşlı uşaq vəfat etmişdir (kalsium çatışmazlığı səbəbindən ürək dayanması). Xelasiya yalnız təsdiqlənmiş ağır metal zəhərlənməsində (qurğuşun və civənin yüksək səviyyəsi) tibbi göstərişlə tətbiq olunur. İD-də effektivliyinə dair sübut yoxdur.

Mif 5: «Kök hüceyrə inyeksiyaları (qeyri-rəsmi klinikalarda) İD-ni sağaldır»

Sübut və risk: Kök Hüceyrə Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Cəmiyyət (ISSCR) və FDA mövqeyi: İD-də (və ümumiyyətlə neyroinkişaf pozuntularında) təsdiqlənmiş kök hüceyrə müalicəsi yoxdur. Qeyri-qanuni «klinikalar» infeksiyalar, beyin şişləri,

ölüm halları ilə müşayiət olunan ciddi yan təsirlərə səbəb olmuşdur (Berkowitz A.L. və b. NEJM 2016).

Mif 6: «Hiperbarik oksigen kamerası (HBOT) İD-nin və autizmin müalicəsidir»

Sübut: Cochrane (Xiong T. və b. 2016) — autizm üçün effekt sübutu yoxdur; İD üçün də sübut bazası yoxdur. Risklər: pnevmotoraks, qulaq barotravması, yanğın (oksigen + statik elektrik).

Mif 7: «Mineral Məhlul» (MMS) / xlor dioksid məhlulu

Sübut: FDA 2019 və Avropa Dərman Agentliyinin (EMA) xəbərdarlığı — kostik (xlor dioksid), qaraciyər və böyrək zədəsi, ölüm halları qeydə alınıb. Bütün klinik istifadə qadağandır.

10.3 Səmərəsiz və ya əsas dəstəyi təxirə salan üsullar

Mif 8: «B qrupu vitaminləri və niasinin yüksək dozaları İD-də koqnitiv funksiyanı bərpa edir»

Sübut: «Ortomolekulyar» psixiatriya yanaşması (Hoffer A., Osmond H. 1950–70) İD-də və autizmdə effektiv olduğu sübut edilməmişdir. Pfeiffer S.I. və b. (J Autism Dev Disord 1995) B6/maqnezium üzrə 12 tədqiqatı təhlil etmiş və metodoloji qüsurlara görə heç bir qəti nəticə çıxarmamışdır (bax: Nye C., Brice A. Cochrane 2005 — eyni nəticə); niasinin yüksək dozaları isə ayrı yanaşma tələb edir — qaraciyər zədəsi və hiperurikemiya yaradır. AAP, AAIDD heç birini tövsiyə etmir.

Mif 9: «Nümunələmə» (patterning; Doman-Delakato metodu)

Niyə yayılıb: 1960–80-ci illərdə kütləvi populyarlıq qazanmışdır; «beyni yenidən proqramlaşdırma» iddiası.

Sübut: AAP-ın 1968 və 2010-cu il bəyanatları: effekt sübutu yoxdur; ailəyə həddən artıq zəhmət və emosional yük; uşaqları digər sübutlu müdaxilələrdən təxirə salır. AAP bu metodu tövsiyə etmir.

Mif 10: «Eşitmə inteqrasiyası təlimi (ing. Auditory Integration Training, AIT)»

Sübut: ASHA (ing. American Speech-Language-Hearing Association) Position Statement 2004 — AIT-in İD və autizmdə effektivliyinə dair sübut yoxdur; eksperimental müdaxilə hesab olunur.

Mif 11: «İD uşaq stimullaşdırılarsa özü-özünə aradan qalxar»

Reallıq: erkən müdaxilə uyğunlaşmanı yaxşılaşdırır, lakin İD bir vəziyyət deyil, neyroinkişaf pozuntusudur — etiologiyası genetik və ya struktur olduqda intellektual qabiliyyət əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməz qalır. Bəzi xüsusi səbəblər (PKU, anadangəlmə hipotireoz) erkən aşkar edilərək tamamilə qarşısı alına bilər — bu, «keçməsi» deyil, vaxtında qarşısının alınmasıdır.

Real klinik addım: AAIDD dəstək modeli — pozuntunun aradan qaldırılması məqsədi yox, mənalı və müstəqil həyatın təminatı; ailəyə realist gözləntilərlə dəstək.

Mif 12: «Valideyn xüsusi pəhriz tətbiq edərsə (qlütensiz, kazeinsiz) İD yaxşılaşar»

Sübut: Hyman S.L. və b. (AAP-ın 2020-ci il ASP üzrə klinik hesabatı): mədə-bağırsaq problemi olmayan uşaqlarda xüsusi pəhrizlərin koqnitiv funksiyaya təsiri sübut edilməmişdir. Çölyak xəstəliyi sübut edilmişdirsə, qlütensiz pəhriz təyin edilir, lakin bu, İD-nin müalicəsi deyil.

11. Mənbələr

1. Şalok R.L., Lukasson R., Tasse M.J. İntellektual əlillik: tərif, diaqnostika, təsnifat və dəstək sistemləri. 12-ci nəşr. Vaşinqton: Amerika Əqli və İnkişaf Əlilikləri Assosiasiyası (AAIDD); 2021.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. Vaşinqton: APA Nəşriyyatı; 2022.
3. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11 Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A00 İntellektual İnkişaf Pozuntuları. 2024.
4. Meşler C.B., Şevell M., Genetika Komitəsi. Əqli əlilliyi və ya ümumi inkişaf gecikməsi olan uşağın kompleks qiymətləndirilməsi. «Pediatriya» (Pediatrics). 2014;134(3):e903–e918 (2020-ci ildə yenidən təsdiqlənib).
5. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NICE Klinik Təlimatı NG54. Öyrənmə əlilliyi olan şəxslərdə psixi sağlamlıq problemləri. 2016.
6. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NICE Klinik Təlimatı NG11. Çətin davranış və öyrənmə əlilikləri: davranışı çətinlik yaradan öyrənmə əlilliyi olan şəxslər üçün qarşısının alınması və müdaxilələr. 2015.
7. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Psixi, nevroloji və maddə istifadəsi pozuntuları üzrə mhGAP müdaxilə təlimatı, 2.0 versiya. Cenevrə: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST); 2016.

8. Maulik P.K., Maskarenhas M.N., Mathers C.D. və b. Əqli əlilliyin yayılması: əhali əsaslı tədqiqatların meta-analizi. «İnkişaf Əlilikləri üzrə Tədqiqatlar» (Res Dev Disabil). 2011;32(2):419–436.
9. Bull M.J. və b. Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP). Daun sindromu olan uşaqlar və yeniyetmələr üçün səhiyyə nəzarəti. «Pediatriya» (Pediatrics). 2022;149(5):e2022057010.
10. Eldevik S., Hastings R.P., Hughes C.K. və b. Autizmi olan uşaqlar üçün Erkən İntensiv Davranış Müdaxiləsinin meta-analizi. «Uşaq və Yeniyetmə Psixologiyası üzrə Klinik Jurnal» (J Clin Child Adolesc Psychol). 2009;38(3):439–450.
11. Ramey C.T., Kempbell F.A. Karolina Abecedarian Layihəsi — uzunmüddətli nəticələr. «Tətbiqi İnkişaf Elmi» (Applied Developmental Science). 2002;6(1):42–57.
12. Nelson K.A., Zeanah C.H., Foks N.A. və b. Sosial cəhətdən məhrum edilmiş kiçik uşaqlarda koqnitiv bərpa: Buxarest Erkən Müdaxilə Layihəsi. «Science» (Science). 2007;318(5858):1937–1940.
13. Teylor L.E., Sverdfeger A.L., Eslick Q.D. Vaksinlər autizmlə əlaqəli deyil: sübuta əsaslanan meta-analiz. «Vaksin» (Vaccine). 2014;32(29):3623–3629.
14. Berkowitz A.L., Miller M.B., Mir S.A. və b. «Kök hüceyrə turizmi»nin ağırlaşması kimi onurğa beyninin qlioproliferativ zədələnməsi. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2016;375(2):196–198.
15. Xiong T., Çen H., Luo R., Mu D. Autizm spektr pozuntusu olan şəxslər üçün hiperbarik oksigen terapiyası. «Cochrane Sistemli İcmallar Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2016;(10):CD010922.
16. Hayman S.L., Levi S.E., Mayers S.M.; Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) Əlilliyi olan Uşaqlar üzrə Şura. Autizm spektr pozuntusu olan uşaqların müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə olunması. «Pediatriya» (Pediatrics). 2020;145(1):e20193447.

XBT-11 **6A01**	**6A01 İNKİŞAF NİTQ VƏ DİL POZUNTULARI** **Developmental speech or language disorders**
XBT-10 F80	Nitq və dilin inkişafının spesifik pozuntuları
DSM-5-TR F80.2	Dil pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

İnkişaf nitq və dil pozuntuları — uşağın eşitmə, intellektual və ya başqa neyroloji səbəblə tam izah olunmayan, dilin və/və ya nitqin əldə edilməsində davamlı və əhəmiyyətli çətinliklərlə təzahür edən neyroinkişaf pozuntuları qrupudur. XBT-11-də 6A01 kodu altında üç alt-tip və dil pozuntusu üçün üç alt dəqiqləşdirmə kodlanır:

- 6A01.0 — İnkişaf nitq səsi pozuntusu (ing. developmental speech sound disorder) — danışıq səslərinin artikulyasiyası və fonoloji formalaşmasında çatışmazlıq;
- 6A01.1 — İnkişaf nitq axıcılığı pozuntusu (ing. developmental speech fluency disorder) — kekələmə (stuttering);
- 6A01.2 — İnkişaf dil pozuntusu (ing. developmental language disorder, DLD) — reseptiv və/və ya ekspressiv dil formalaşmasında pozulma (alt dəqiqləşdirmələr: 6A01.20 reseptiv-ekspressiv, 6A01.21 əsasən ekspressiv, 6A01.22 əsasən praqmatik);
- 6A01.Y — Digər dəqiqləşdirilmiş inkişaf nitq və dil pozuntuları.

DSM-5-TR-də paralel terminologiya: Dil pozuntusu (ing. Language Disorder, F80.2), nitq səsi pozuntusu (ing. Speech Sound Disorder, F80.0), uşaqlıq dövrü axıcılıq pozuntusu (ing. Childhood-Onset Fluency Disorder/Stuttering, F80.81), sosial (praqmatik) ünsiyyət pozuntusu (Social (Pragmatic) Communication Disorder, F80.82).

2. Tarixçə

- Spesifik dil pozuntusu (ing. Specific Language Impairment, SLI) — 1980-ci illərdən 2010-cu illərə qədər istifadə edilən termin; «spesifik» sözü zaman keçdikcə tənqid edilmişdir, çünki dil pozuntusu çoxsaylı koqnitiv və davranış sahələri ilə üst-üstə düşür.
- CATALISE konsensusu (Bishop D.V.M. və b. PLoS One 2016; J Child Psychol Psychiatry 2017) — 59 beynəlxalq mütəxəssisin Delfi konsensusu: «SLI» termini «inkişaf dil pozuntusu» (Developmental Language Disorder, DLD) ilə əvəz edilmişdir. Diaqnoz üçün IQ kəsim həddi (≥85) ləğv edilmiş, funksional pozulma əsas götürülmüşdür.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — DLD termini qəbul edilmişdir; sosial-praqmatik ünsiyyət pozuntusu autizm spektri pozuntusundan ayrı kateqoriya kimi tanınmışdır (DSM-5-də yeni; XBT-11-də 6A01.22 alt-tipi kimi).
- Kekələmə üzrə bioloji-genetik konsepsiya 2000-ci illərdən sonra üstünlük təşkil etmişdir (GNPTAB, GNPTG, NAGPA mutasiyaları — Kang C. və b. NEJM 2010).

3. Epidemiologiya

- DLD (6A01.2): 5–6 yaşda yayılma tezliyi (prevalans) 7,58% (Norbury C.F. və b. J Child Psychol Psychiatry 2016, əhali əsaslı tədqiqat, n=7267 İngiltərə).
- Nitq səsi pozuntusu (6A01.0): 6 yaşda təxminən 3,8% (Shriberg L.D. və b. J Speech Lang Hear Res 1999); məktəbəqədər yaşda daha yüksək.
- Kekələmə (6A01.1): uşaqlıqda kumulyativ insidens 5–8% (təxminən hər 20 uşaqdan birində kekələmə müşahidə olunur); yetkinlikdə davam edən yayılma təxminən 1% (Yairi E., Ambrose N. J Fluency Disord 2013).
- Cins: bütün alt-tiplərdə oğlanlarda qızlara nisbətən 2–4 dəfə yüksək rast gəlinir.
- Komorbidlik: öyrənmə pozuntuları 40–60%, DDHP 20–30%, autizm spektri 5–10%, narahatlıq və davranış pozuntuları üzrə risk artmışdır.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

- DLD irsiliyi 50–75% əkiz tədqiqatlarında (Bishop D.V.M. Trends Cogn Sci 2014).
- FOXP2 mutasiyaları — KE ailəsində nadir ağır nitq-dil pozuntusu (Lai C.S. və b. Nature 2001); əksər hallarda poligen xarakter daşıyır.
- Kekələmə: təxminən 70% irsilik (Felsenfeld S. və b. Behav Genet 2000 əkiz tədqiqatı); lizozomal yol genlərində (GNPTAB, GNPTG, NAGPA) mutasiyalar nadir hallarda (təxminən 9%) aşkar olunur.
- CNV və GWAS tədqiqatları — poligen risk arxitekturası DLD üçün də xarakterik.

4.2 Neyrobioloji

- Sol perisilvian (Broca və Wernicke ətrafı), arkuat fascikulus (arcuate fasciculus) və bazal qanqliyaların inkişafında qeyri-tipik modellər.
- Kekələmədə bazal qanqliyalar — əlavə motor sahəsi əlaqəsində dopaminergik disfunksiya (Maguire G.A. və b. Curr Med Res Opin 2020 icmal).
- Erkən beyin asimmetriyası — DLD-də sol hemisfera dil sahələrinin tipik dominantlığının zəifləməsi.

4.3 Risk amilləri

- Ailədə dil/nitq pozuntusu tarixçəsi (ən güclü risk amili).

- Erkən doğum, aşağı doğum çəkisi.
- Xronik orta qulaq iltihabı (otit) erkən uşaqlıqda — eşitmənin dəyişkənliyi dilin əldə edilməsinə təsir göstərə bilər.
- Aşağı sosial-iqtisadi status — risk amili kimi göstərilir, lakin etiologiya deyil; məhrum mühit dil inkişafına təsir göstərir.
- İkidillilik (bilingvizm) — risk amili deyil (genişlənmiş mövzu §10).

4.4 Qarşısı alına bilən və müalicə oluna bilən səbəblər

- Eşitmə pozuntusu — yeni doğulmuşlarda eşitmə skrininqi proqramı (UNHS) və orta qulaq iltihabının vaxtında müalicəsi kritikdir.
- Anadangəlmə dodaq-damaq yarığı — cərrahi düzəliş və nitq terapiyası.
- Hipotireoz — yeni doğulmuşlarda skrininq müayinəsi.

5. Klinik təzahürlər

6A01.0 Nitq səsi pozuntusu

- Yaşa uyğun olmayan səs buraxma, əvəzləmə, təhrif (məsələn, «r» → «l», «s» → «t»).
- Nitqin aydın olmaması — kənar şəxslər nitqi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
- 4 yaşa qədər inkişaf çərçivəsində «yumşaq» hesab edilir; 4 yaşdan sonra davam edənlər yenidən diaqnostik qiymətləndirilməlidir.

6A01.1 Nitq axıcılığı pozuntusu (kekələmə)

- Səslərin və hecaların təkrarlanması (b-b-b-balıq), uzanma (sssalam), bloklar (səsi başlatmadan duruş).
- İkincili davranışlar — göz təmasından qaçınma, baş silkələmə, qaçınma.
- Başlanğıc adətən 2–5 yaş arasında olur; kekələyən uşaqların təxminən 70–80%-i 5 il ərzində spontan və ya müdaxilə ilə bərpa olur (Yairi E., Ambrose N. 2013).
- Sosial və emosional yük — sosial narahatlıq, məktəbdən yayınma.

6A01.2 İnkişaf dil pozuntusu (DLD)

- Ekspressiv komponenti: məhdud lüğət, qısa cümlələr, qrammatik morfologiyada xətalar (xüsusilə zaman, hal sonluqları), söz tapma çətinliyi.
- Reseptiv komponenti: mürəkkəb cümlələri başa düşməkdə çətinlik, şifahi göstərişləri yerinə yetirməkdə çətinlik, məcazi məna və mücərrəd dilin mənimsənilməsi geri qalır.

- Praqmatik komponenti (6A01.22): sosial dilin istifadəsində (növbə, kontekst, dolayı nitq) çatışmazlıq; autizmdən fərqli olaraq sosial maraq və qeyri-verbal ünsiyyət nisbətən sağlamdır.

İnkişaf trayektoriyası

«Gec danışan» (late talker) 2 yaşda kateqoriya — 50–70%-i 4 yaşa qədər yaşıdlarının səviyyəsinə çatır; lakin davam edən qrup DLD üçün yüksək risk təşkil edir. Bu qrupun erkən identifikasiyası ailə tarixçəsi, reseptiv çatışmazlıq və qeyri-verbal jestlərin az istifadəsi əlamətlərinə əsaslanır.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11, CATALISE 2017 konsensus nöqtələri)

A. Dil və ya nitq əldə edilməsində davamlı çatışmazlıq — bir və ya bir neçə sahə (lüğət, sintaksis, fonologiya, axıcılıq, praqmatika) yaşa uyğun normadan aşağı göstərici.

B. Funksional pozulma — akademik nailiyyət, sosial ünsiyyət, peşə fəaliyyəti və ya gündəlik həyat sahələrindən birində və ya bir neçəsində əhəmiyyətli məhdudiyyət (CATALISE: funksional pozulma diaqnoz üçün vacibdir, IQ kəsim həddi deyil).

C. Başlanğıc inkişaf dövrünə təsadüf edir.

D. İstisnalar — eşitmə pozuntusu, neyroloji vəziyyət, intellektual əlillik, autizm spektri pozuntusu və ya digər tibbi və ya psixiatrik vəziyyətlə tam izah olunmur. Lakin komorbidlik mövcud olduqda hər iki diaqnoz qoyulur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- CATALISE 2017 (Bishop D.V.M. və b.): «spesifik» termini ləğv; IQ kəsim həddi 85 ləğv (DLD intellektual əlillik fonunda da diaqnoz oluna bilər); «dil pozuntusu» ümumi başlığı altında komorbid neyroinkişaf və risk amilləri kvalifikator kimi göstərilir.
- XBT-11 (6A01): alt-tiplərin (səs, axıcılıq, dil) ayrı-ayrı kodlanması; dil pozuntusu üçün 3 alt-spesifikasiya (reseptiv-ekspressiv, əsasən ekspressiv, əsasən praqmatik).
- DSM-5-TR: Sosial (praqmatik) ünsiyyət pozuntusu ayrı kateqoriya kimi (F80.82); kekələmə üçün başlanğıc yaşı tipik <6 yaş.
- ASHA Practice Portal: diaqnostika üçün sertifikatlı nitq-dil patoloqu (NDP) tərəfindən standartlaşdırılmış qiymətləndirmə, valideyn müsahibəsi və naturalistik müşahidə birgə tələb olunur.

- RCSLT (ing. Royal College of Speech and Language Therapists): Böyük Britaniyada eyni çərçivə; multidissiplinar qiymətləndirmə (eşitmə + nitq-dil + inkişaf).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

4. Valideyn və müəllim müsahibəsi (inkişaf tarixçəsi, dil mərhələləri).
5. Eşitmə testi (audiometriya — bütün hallarda mütləq).
6. Nitq və dilin standartlaşdırılmış qiymətləndirilməsi (CELF-5, PLS-5, GFTA-3, DELV).
7. Naturalistik nitq nümunəsi (oyun və ya söhbət şəraitində).
8. Qeyri-verbal IQ ölçüsü (ASP və intellektual əlillik istisnası üçün).
9. Autizm spektri skrininq (M-CHAT-R/F — 30 aydan kiçik uşaqlar üçün; SCQ — məktəbəqədər yaşlılar üçün).
10. Sosial-emosional və davranış pozuntuları üzrə skrininq.
11. Tibbi müayinə — neyroloji, dodaq və damaq nahiyəsinin müayinəsi, motor müayinəsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
İntellektual əlillik (6A00)	Ümumi koqnitiv çatışmazlıq dil pozuntusundan kənar bütün domenlərə yayılır. Komorbid ola bilər.
Autizm spektri pozuntusu (6A02)	Sosial ünsiyyət və məhdud-təkraralanan davranış ikilisi; praqmatik dil də pozulmuşdur, lakin sosial motivasiya əsas problem.
Eşitmə pozuntusu	Audiometriya pozulmuş; reseptiv çatışmazlıq dominant.
Selektiv mutizm (6B06)	Müəyyən sosial vəziyyətlərdə danışmama (məktəb), digər kontekstdə (ev) normal nitq.
Çoxdilli mühitin keçici təsiri	Yaşa uyğun mühit dilinin mənimsənilməsi davam edir; nitq dinamik olaraq inkişaf edir.
İkidillilikdə «kod qarışıqlığı»	Tipik və inkişafa uyğundur, pozuntu deyil.

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Uşaqlıq danışıq apraksiyası (ing. childhood apraxia of speech, CAS)	Motor-planlaşdırma çatışmazlıq, dəyişkən səs istehsalı, ardıcıllıq problemi.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Standartlaşdırılmış testlər

- Dil: CELF-5 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals, 5–21 yaş), PLS-5 (Preschool Language Scales, <7 yaş), CASL-2 (ing. Comprehensive Assessment of Spoken Language-2), Reynell İnkişaf Dil Şkalaları.
- Lüğət ehtiyatı: PPVT-5 (ing. Peabody Picture Vocabulary Test), EVT-3, MacArthur-Bates CDI (ing. Communicative Development Inventories, 8–30 ay).
- Nitq səsi: GFTA-3 (ing. Goldman-Fristoe Test of Articulation), DEAP (ing. Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology).
- Praqmatik dil: CCC-2 (Uşaqların ünsiyyət Yoxlama Siyahısı), Test of Pragmatic Language (TOPL-2).
- Qeyri-verbal IQ: Leiter-3, RIAS-2 (şifahi komponentdən asılı olmadan).

7.2 Laborator müayinələr

Mütləq deyil; Mütləq deyil; xüsusi şübhə əsasında::

- Eşitmə testi — bütün hallarda mütləq (audiometriya, timpanometriya, otoakustik emissiya).
- X kövrək sindromu (ing. Fragile X; FMR1) — ağır DLD və intellektual əlilliklə komorbid hallarda.
- Tiroid funksiyası (TSH, T4) — anadangəlmə hipotireoz aşkar edilməmişsə.
- Qurğuşun səviyyəsi — risk amilləri varsa.

7.3 Alət müayinələri

- Beyin MRT — fokal nevroloji əlamətlər, reqressiya, makro/mikrosefaliya, tutmalar olduqda. Adi hallarda DLD-də göstəriş yoxdur.
- EEQ — tutma şübhəsi olduqda, Landau-Kleffner sindromu istisnası üçün.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (ASHA, RCSLT, CATALISE, NICE konsensus)

3. Sertifikatlı nitq-dil patoloqu (SLP) tərəfindən fərdi nitq-dil terapiyası bütün pozuntularda birinci xətt müdaxiləsidir.
4. Erkən müdaxilə — 2–4 yaş arasında aparılan müdaxilə daha yüksək effektivlik verir; «gözlə və izlə» yanaşması müəyyən risk amilləri (ailə tarixçəsi, reseptiv çatışmazlıq) varsa zərərlidir.
5. Valideyn-koordinasiyalı (parent-coached) müdaxilələr kiçik yaşda — Hanen «It Takes Two to Talk» proqramı reaktiv bağlanma pozuntusu (RPP) hallarında effekt göstərmişdir.
6. İntensivlik və müddət — həftədə 1–3 seans, 6–18 ay, davranış və akademik komponentlərə görə fərdləşdirilir.
7. Multidissiplinar yanaşma — nitq-dil patoloqu (SLP), müəllim, pediatr və lazım olduqda audioloq, ergoterapevt, psixoloq.
8. Məktəbdə dəstək — fərdi təhsil planı (IEP / EHCP), sinif modifikasiyaları, lazım olduqda fərdi kömək.
9. İkidillilik qorunur — uşağın hər iki dilini saxlamasına dəstək verilir; bir dildən «imtina etmək» tövsiyə olunmur (ing. ASHA Position 2004).
10. Farmakoterapiya nitq-dil pozuntusunun özü üçün təsdiqlənməmişdir. Komorbid DDHP, narahatlıq və ya autizm üçün ayrıca müdaxilə tələb olunur.

8.2 Nitq səsi pozuntusunda müdaxilə (6A01.0)

- Artikulyasiya terapiyası — fonem-fonem yanaşması (ing. Van Riper) və minimal cütlük təlimindən ibarətdir (yaxın səslərin kontrast cütlərdə müqayisəsi).
- Fonoloji proseslərin azaldılması — sistematik proses əsaslı terapiya (Bowen C., Cupples L. 1999).
- Kompleks və ağır hallarda PROMPT (ing. Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) və multisensor yanaşma tətbiq olunur.

8.3 Kekələmədə müdaxilə (6A01.1)

- Lidcombe Proqramı (Onslow M., Avstraliya Kekələmə Tədqiqat Mərkəzi) — 3–6 yaşda birinci xətt; valideyn-koordinasiyalı, evdə tətbiq olunan müsbət gücləndirmə əsaslı operant proqram. Sübut: Jones M. və b. BMJ 2005 RKİ, n=54 — 9 aydan sonra kekələnən hecaların payı müalicə qrupunda 1,5% (standart kənaraçıxma 1,4), nəzarətdə 3,9% (SD 3,5); fərq

2,3 faiz bəndi (95% ET 0,8–3,9; p=0,003). Cochrane 2021 icmalı sübutun keyfiyyətini çox aşağı qiymətləndirir.

- Demands and Capacities Model (DCM) — Starkweather C.W. — kommunikativ tələblərin uşağın hazırkı qabiliyyətinə uyğunlaşdırılması.
- Yaşlı uşaqlar/yetkinlər — kekələmənin modifikasiyası (ing. stuttering modification; Van Riper) və axıcılığın formalaşdırılması (ing. fluency shaping; Webster); ailə və qrup dəstəyi.
- Farmakoterapiya: FDA-da kekələmə üçün rəsmi təsdiqlənmiş dərman yoxdur. Təsdiqlənməmiş göstərişlər üzrə (ing. off-label) dopamin antaqonistləri (risperidon, olanzapin) və SSGİ-lər (paroksetin) seçilmiş yetkin hallarda tədqiq edilmişdir, lakin effekti mülayimdir və yan təsir profili əhəmiyyətlidir (Maguire G.A. və b. 2020 icmal).

8.4 İnkişaf dil pozuntusunda müdaxilə (6A01.2)

- Hanen «It Takes Two to Talk» — 2–4 yaşda valideyn-koordinasiyalı qrup proqramı; uşağın təşəbbüsünü dəstəkləmə, dialoqun genişləndirilməsi. Sübut: Roberts M.Y., Kaiser A.P. Am J Speech Lang Pathol 2011 meta-analiz — ekspressiv və reseptiv dil ölçülərində orta effekt.
- Təbii dil müdaxiləsi (ing. enhanced milieu teaching, focused stimulation) — uşağın maraqları kontekstində dil modellərinin təqdim edilməsi.
- Strukturlaşdırılmış morfo-sintaktik terapiya — qrammatik formaların hədəfli təlimi (məsələn, keçmiş zaman, cəm).
- Praqmatik dil müdaxilələri (6A01.22) — sosial hekayələr (ing. Social Stories; Kerol Qrey), video modelləşdirmə (ing. video modelling), qrup təlimi.
- Məktəb yaşında akademik dəstək — oxuma çətinliklərinin yüksək komorbidliyi səbəbilə Strukturlaşdırılmış savadlılıq (ing. Structured Literacy) yanaşması; öyrənmə pozuntusu üzrə qiymətləndirmə.

8.5 Müalicə metodları

3. Hanen «Danışmaq üçün iki nəfər lazımdır» (ing. It Takes Two to Talk) proqramı — Kanadada Hanen Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış, gec danışan və DLD riski olan 2–4 yaşlı uşaqlar üçün valideyn təlimi proqramı. 8 qrup seansı və 3 fərdi ev ziyarəti nəzərdə tutulur; «OWL» (Observe, Wait, Listen) və uşağın liderliyini izləmə prinsipləri. Sübut: Roberts M.Y., Kaiser A.P. Am J Speech Lang Pathol 2011 meta-analiz. hanen.org.
4. Lidcombe Proqramı — Avstraliyada Onslow M. tərəfindən hazırlanmış, məktəbəqədər yaşda kekələmə üçün davranış əsaslı valideyn-koordinasiyalı proqram. Valideyn gündəlik 10–15 dəqiqə oyun seansında uşağın axıcı

nitqini gücləndirir. Sübut: Jones M. və b. BMJ 2005 RKİ n=54, 9 ay; Onslow M. və b. icmalları. lidcombeprogram.org.

5. Gücləndirilmiş Mühit Təlimi (EMT — ing. Enhanced Milieu Teaching) — Naturalistik dil müdaxiləsi — uşağın oyun və gündəlik kontekstində ardıcıl dil modellərinin təqdim edilməsi və genişləndirilməsi. Sübut: Kaiser A.P., Roberts M.Y. Am J Speech Lang Pathol 2013.
6. PROMPT metodu (ing. Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) — Taktil-kinestetik nitq-motor müdaxiləsi — uşağın ağız əzələlərinə fiziki sensor işarəsi ilə düzgün artikulyasiya yerinin göstərilməsi. Kompleks nitq səsi pozuntusu və uşaqlıq nitq apraksiyasında istifadə olunur. Sübut bazası inkişaf etməkdədir; Rogers S.J. və b. 2006 (autizm fonunda) və başqa pilot tədqiqatlar.
7. Sosial Hekayələr (ing. Social Stories) — Kerol Qrey (ing. Carol Gray) — Sosial kontekstdə uyğun davranışın qısa, fərdiləşdirilmiş hekayə formatında təlimi. Praqmatik dil pozuntusu və autizm spektrində bu bacarıqların formalaşdırılmasında istifadə olunur. carolgraysocialstories.com.
8. Dil Əsaslarının Klinik Qiymətləndirməsi (ing. Clinical Evaluation of Language Fundamentals, CELF-5) — 5–21 yaş üçün dilin standartlaşdırılmış kompleks qiymətləndirməsi — reseptiv, ekspressiv, dil yaddaşı, söz-cümlə quruluşu.
9. Məktəbəqədər Dil Şkalası (PLS-5 — Preschool Language Scales) — Doğuşdan 7 yaşa qədər dil qiymətləndirməsi — eşitmə anlayışı (ing. auditory comprehension) və ekspressiv ünsiyyət (ing. expressive communication) şkalaları.
10. Uşaq ünsiyyət Yoxlama Siyahısı (CCC-2) (ing. CCC-2 — Children's Communication Checklist) — Praqmatik dil və ümumi kommunikativ funksiyanın valideyn/müəllim qiymətləndirməsi; DLD-nin alt-tipləşdirilməsində kömək edir.

8.6 Mənbələr arasında fərqlər

- ASHA Təcrübə Portalı: sübuta əsaslanan təcrübə çərçivəsi — klinik mühakimə, sübut və ailə dəyərləri üçlüyü; sertifikatlaşdırma və davamlı təhsil tələbləri.
- RCSLT (ing. 2017 Position Paper on DLD): erkən müəyyən etmə və xidmət əlçatanlığı təklif edir; «Bercow» hesabatı (2008, 2018) İngiltərədə xidmət strukturunu formalaşdırmışdır.
- NICE NG (uşaq nitqi və dili üzrə ayrıca tam təlimat hələ hazırlanma mərhələsindədir; mövcud təlimat təhsil və sağlamlıq xidmətlərinin koordinasiyasına yönəlir).

- WHO mhGAP IG v2.0: gəlir səviyyəsi aşağı və orta olan ölkələrdə birinci tibbi yardım səviyyəsində qiymətləndirmə; valideyn təlimi və icma əsaslı reabilitasiya vurğulanır.

9. Proqnoz

Yaxşı proqnoz amilləri

- Yüngül-orta şiddət, yalnız ekspressiv komponent.
- Erkən identifikasiya (<3 yaş) və müdaxilə.
- Yüksək qeyri-verbal IQ.
- Komorbid pozuntuların olmaması (ASP, intellektual əlillik).
- Valideyn iştirakı və evdə dil-zəngin mühit.

Pis proqnoz amilləri

- Reseptiv komponentin ağırlığı (yalnız ekspressiv pozuntudan daha pis proqnoz).
- Komorbid intellektual əlillik və ya ASP.
- Gec identifikasiya (>5 yaş).
- Ailə tarixçəsində davamlı DLD.
- Aşağı sosial-iqtisadi dəstək, məhdud xidmət əlçatanlığı.

İzləmə hədəfləri

- DLD olan uşaqlarda oxuma və yazma çətinliklərinin yüksək komorbidliyi (40–60%) — məktəbəqədər yaşda fonoloji fərqindəlik təlimi; sonra Strukturlaşdırılmış savadlılıq (ing. Structured Literacy).
- Sosial-emosional sağlamlıq — DLD-li yeniyetmələrdə narahatlıq və depressiya riski artmışdır (Conti-Ramsden G., Botting N. J Child Psychol Psychiatry 2008).
- Davranış pozuntusu və DDHP üzrə skrininq aparılır.
- Yeniyetməlik dövründə peşə yönümü və akademik dəstək planlaşdırılır.
- Kekələmə remissiyaya çatdıqdan sonra təkrar halların izlənməsi (stress dövrlərində).

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «Bilingvallıq (iki dildə danışmaq) uşaqda dil pozuntusuna səbəb olur»

Niyə yayılıb: ailələr və bəzən pediatrlar tərəfindən «dilləri qarışdırma» «uşağı çaşdırır» şəklində təlqin edilir; gec danışan ikidilli uşaqlarda hər iki dildə lüğət birdilli uşaqlarla müqayisədə kiçik görünə bilər (lakin ümumi anlayış lüğəti ekvivalentdir).

Klinik və bioloji məntiq: insan beyni doğuşdan bir neçə dildə inkişaf etmək üçün uyğunlaşmışdır; bilingvallıq icraedici funksiyalara və koqnitiv elastikliyə müsbət təsir göstərir (Bialystok E. və b. Trends Cogn Sci 2012 icmal). DLD-li bilingual uşaqlar hər iki dildə eyni paterndə pozulma göstərir — bu, dilin sayı ilə bağlı deyil, neyroinkişaf pozuntusu ilə bağlıdır.

Sübut: Paradis J., Genesee F., Crago M.B. (2011) — bilingual uşaqlarda dil əldə etməsi birdilli uşaqlardakı qanunauyğunluqlarla paralel inkişaf edir; DLD bilingvallığa görə yox, neyroinkişaf əsaslı yaranır.

Real klinik addım: bilingual uşağa DLD diaqnozu yalnız hər iki dildə pozulma sənədləşdirildikdə qoyula bilər. Ailənin ana dilini kəsmək tövsiyə edilmir sosial-emosional zərərə və ailə bağının pozulmasına səbəb olur.

Mif 2: «Kekələmə valideynin yanlış davranışından (səbirsizlik, sərtlik) yaranır»

Niyə yayılıb: 1940–1950-ci illərdə Uendell Consonun «diaqnozogen nəzəriyyə»si — kekələmə valideynin uşağın normal qeyri-axıcılığına diqqət çəkməsi nəticəsində yarandığı iddiası; sonradan ləğv edilmiş, lakin kütləvi inancda qalmışdır.

Bioloji məntiq və sübut: kekələmə genetik və neyrobioloji əsaslıdır — irsilik təxminən 70% (Felsenfeld 2000); GNPTAB və əlaqəli lizozomal yol mutasiyaları nadir formalarda (Kang C. NEJM 2010); fMRT tədqiqatları bazal qanqliyalar və əlavə motor sahəsi (ing. supplementary motor area) dövrəsində funksional pozulma göstərir (Maguire 2020). Valideynin reaksiyası kekələmənin davamlılığına təsir göstərə bilər (stress kontekstində artması), lakin kekələmənin başlanğıcına səbəb deyil.

Praktik klinik addım: ailəyə dəstək — sakit, dinləyən mühit yaratmaq; Lidcombe Proqramı kimi sübutlu valideyn-koordinasiyalı müdaxilə.

Mif 3: «Uşaq danışmırsa, çünki „tənbəldir“ və ya „çox kiçikdir, gözləyək“»

Sübut: «gözlə və gör» (ing. wait and see) yanaşması yalnız risk amilləri olmayan gec danışan uşaq üçün uyğundur — bu qrupun 70–80%-i 4 yaşa qədər yaşıdlarının səviyyəsinə çatır. Lakin risk amilləri olanda (ailə tarixçəsi, reseptiv çatışmazlıq, qeyri-verbal jestlərin az istifadəsi, eşitmə şübhəsi) gözləmə kritik müdaxilə pəncərəsini itirir — Roos E.M., Weismer S.E. Top Lang Disord 2008.

Real klinik addım: 18–24 ayda skrininq (CDI, ASQ); risk amilləri varsa nitq-dil patoloqu (SLP) qiymətləndirməsi.

10.2 Zərərli və ya əsas müdaxiləni təxirə salan üsullar

Mif 4: «Dil bağı (tongue-tie / ankyloglossia) cərrahiyyəsi nitq problemini həll edər»

Niyə yayılıb: «frenotomiya» və «frenuloplastika» prosedurlarının kommersiya populyarlığı; əmizdirmə problemlərində bəzi göstərişlərin olması.

Sübut: Yalnız ağır anatomik məhdudiyyət (Coryllos III–IV) və əmizdirmə problemi varsa frenotomy effektivdir (AAP, ABM 2020 protokolları). Nitq səsi pozuntusu üçün sistemli sübut yoxdur — Webb A.N. və b. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013 icmal. Səhv əməliyyat — qanaxma, infeksiya, ikiqat frenum yaranması, normal əmizdirmənin çətinləşməsi.

Real klinik addım: nitq səsi pozuntusu üçün birinci xətt — nitq-dil patoloqu (SLP) qiymətləndirməsi və artikulyasiya terapiyası, frenotomy yox.

Mif 5: «Eşitmə inteqrasiyası təlimi «Eşitmə inteqrasiyası təlimi» (ing. Auditory Integration Training; AIT) — Berard və ya Tomatis metodu»

Niyə yayılıb: alternativ klinikaların marketinqi; «eşitmə sisteminin yenidən proqramlaşdırılması» iddiası.

Sübut: ASHA Position Statement 2004 — eşitmə-dil və ya autizmdə effekt sübutu yoxdur; eksperimental status. AAP 1998 Statement — AIT tövsiyə etmir.

Mif 6: «Kekələmənin hipnoterapiya, qulaq cihazları (ing. DAF — delayed auditory feedback) ilə tam müalicəsi»

Sübut: Hipnoterapiya — kekələmə üçün effekt sübutu yoxdur (Bothe A.K. və b. Am J Speech Lang Pathol 2006 icmal). DAF cihazları (SpeechEasy və oxşar) bəzi yetkinlərdə qısamüddətli axıcılığın artmasına səbəb ola bilər, lakin uzunmüddətli effekti məhduddur və davranış terapiyası ilə müqayisədə üstünlüyü təsdiqlənməyib (Lincoln M., Packman A. J Fluency Disord 2007).

10.3 Səmərəsiz və ya elmi əsası olmayan üsullar

Mif 7: «Non-Speech Oral Motor Exercises (NSOME) — dil, dodaq, çənə məşqləri nitq səsini düzəldir»

Niyə yayılıb: intuitiv əsas — «əgər əzələ məşq edilsə, daha yaxşı işləyər»; bəzi terapevtlər tərəfindən hələ də tətbiq edilir.

Sübut: ASHA 2009 və yenilənmə — nitq olmayan oral motor məşqlərin nitq səsi pozuntusunda effekt sübutu yoxdur; nitq və nitq olmayan oral hərəkətlər ayrı neyromotor proqramlardır (McCauley R.J., Strand E., Lof G.L. Am J Speech Lang Pathol 2009 sistemli icmal). NSOME istifadəsi terapiya vaxtını sübutlu nitq əsaslı müdaxilədən yayındırır.

Real klinik addım: nitq səsi pozuntusu üçün — birbaşa artikulyasiya terapiyası (fonem-fonem və ya fonoloji proseslər); NSOME-dən qaçınılır.

Mif 8: «Brain Gym / Edu-K — beyin koordinasiyası məşqləri dil pozuntusunu sağaldır»

Sübut: İcmallar (Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007) — «Brain Gym» iddiaları neyrobiologiya ilə uzlaşmır; öyrənmə nəticələrinə təsir göstərmir. Kommersiya proqramı kimi tənqid edilir.

Mif 9: «Hiperbarik oksigen kamerası (HBOT) və kök hüceyrə yeridilmələri dil pozuntusunu sağaldır»

Sübut: Cochrane (Xiong T. 2016 — autizm; oxşar mövqe DLD üçün) — effekt sübutu yoxdur; HBOT-da pnevmotoraks, barotravma riskləri; qeyri-rəsmi kök hüceyrə klinikalarında ölüm halları (Berkowitz NEJM 2016).

Mif 10: «Xüsusi pəhriz (qlütensiz, kazeinsiz) dil pozuntusunu sağaldır»

Sübut: ASHA, AAP, AACAP — nitq və dil pozuntularına xüsusi pəhrizlərin təsiri sübut olunmayıb. Çölyak xəstəliyi və ya təsdiqlənmiş qida allergiyası varsa pəhriz tibbi göstərişdir, lakin nitq-dil inkişafına təsiri yoxdur.

11. Mənbələr

6. Bişop D.V.M., Snoulinq M.C., Tompson P.A., Qrinkalç T., CATALISE konsorsiumu. CATALISE: dil inkişafı ilə bağlı problemlərin çoxmillətli və multidissiplinar Delphi konsensus tədqiqi: Terminologiya. «Uşaq Psixologiyası və Psixiatriyası Jurnalı» (J Child Psychol Psychiatry). 2017;58(10):1068–1080.

7. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11 Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A01 İnkişaf xarakterli nitq və ya dil pozuntuları. 2024.
8. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. Vaşinqton: APA Nəşriyyatı; 2022.
9. Amerika Nitq-Dil-Eşitmə Assosiasiyası (ASHA). Praktika Portalı — Dil Pozuntuları, Nitq Səsi Pozuntuları, Axıcılıq Pozuntuları. asha.org/practice-portal.
10. Danışıq və Dil Terapiyası üzrə Kral Kolleci (RCSLT). İnkişaf xarakterli dil pozuntusu. rcslt.org.
11. Norburi K.F., Quç D., Vray K. və b. Qeyri-verbal qabiliyyətin dil pozuntusunun yayılmasına və klinik təzahürünə təsiri. «Uşaq Psixologiyası və Psixiatriyası Jurnalı» (J Child Psychol Psychiatry). 2016;57(11):1247–1257.
12. Yairi E., Ambroz N. Kəkələmənin epidemiologiyası: 21-ci əsrin irəliləyişləri. «Kəkələmə Pozuntuları Jurnalı» (J Fluency Disord). 2013;38(2):66–87.
13. Cons M., Onslou M., Pakman A. və b. Erkən kəkələmə müdaxiləsi üzrə Lidkom proqramının randomizə edilmiş nəzarətli sınağı. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2005;331(7518):659.
14. Roberts M.Y., Kayzer A.P. Valideynlər tərəfindən həyata keçirilən dil müdaxilələrinin effektivliyi: meta-analiz. «Amerika Nitq-Dil Patologiyası Jurnalı» (Am J Speech Lang Pathol). 2011;20(3):180–199.
15. MakKoli R.C., Strend E., Lof C.L. və b. Sübuta əsaslanan sistemli icmal: nitqdən kənar oral-motor məşqlərinin nitqə təsirləri. «Amerika Nitq-Dil Patologiyası Jurnalı» (Am J Speech Lang Pathol). 2009;18(4):343–360.
16. Bişop D.V.M. İzahı olmayan dil problemləri olan uşaqlar üçün terminologiya haqqında on sual. «Beynəlxalq Dil və Ünsiyyət Pozuntuları Jurnalı» (Int J Lang Commun Disord). 2014;49(4):381–415.
17. Felsenfeld S., Kirk K.M., Cu Q. və b. Seçilmiş əkiz nümunəsində kəkələmənin genetik və ekoloji etiologiyasının tədqiqi. «Davranış Genetikası» (Behav Genet). 2000;30(5):359–366.
18. Kanq C., Riazuddin S., Mundorf C. və b. Lizosom fermentinin hədəflənmə yolu ilə bağlı mutasiyalar və davamlı kəkələmə. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2010;362(8):677–685.
19. Maguayr C.A., Yeh C.Y., Ito B.S. Kəkələmənin diaqnostikası və müalicəsinə ümumi baxış. «Cari Tibbi Tədqiqat və Rəylər» (Curr Med Res Opin). 2020;36(8):1399–1407.

20. Paradis C., Genesee F., Krago M.B. İkitərəfli dil inkişafı və pozuntuları: ikidillilik və ikinci dil öyrənməsi üzrə dərslik. 2-ci nəşr. Brookes Publishing; 2011.
21. Bialystok E., Krayk F.I.M., Luk Q. İkidillilik: şüur və beyin üçün nəticələr. «Koqnitiv Elmlər Tendensiyaları» (Trends Cogn Sci). 2012;16(4):240–250.
22. Konti-Ramsden Q., Botting N. Xüsusi dil pozuntusu tarixçəsi olan və olmayan yeniyetmələrdə emosional sağlamlıq. «Uşaq Psixologiyası və Psixiatriyası Jurnalı» (J Child Psychol Psychiatry). 2008;49(5):516–525.
23. Starkvezer K.V. Nitq axıcılığı və kəkələmə. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 1987.
24. Şriberg L.D., Tomblin C.B., MakSveyni C.L. 6 yaşlı uşaqlarda nitq gecikməsinin yayılması və dil pozuntusu ilə komorbidlik. «Nitq, Dil və Eşitmə Tədqiqatları Jurnalı» (J Speech Lang Hear Res). 1999;42(6):1461–1481.

XBT-11 **6A02**	**6A02 AUTİZM SPEKTRİ POZUNTUSU (ASP)** **Autism spectrum disorder**
XBT-10 F84.0	Uşaq autizmi
DSM-5-TR F84.0	Autizm spektri pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Autizm spektri pozuntusu (ing. ASP; XBT-11: 6A02; DSM-5-TR: F84.0 Autism Spectrum Disorder) — erkən inkişaf dövründə başlayan, iki əsas sahə davamlı defisitlərlə müşayiət olunan neyroinkişaf pozuntusudur:

8. Sosial ünsiyyət və sosial qarşılıqlı əlaqədə davamlı çatışmazlıq — qarşılıqlı sosial-emosional mübadilə, qeyri-verbal kommunikativ davranış, münasibətlərin formalaşdırılması və qorunması.
9. Məhdud, təkrarlanan davranış, maraq və ya fəaliyyət modelləri — stereotipik motor hərəkətlər və ya nitq, sabit ritual və rutinlərə bağlılıq, məhdud yüksək intensivlikli maraqlar, sensor qıcıqlara qeyri-tipik reaktivlik.

XBT-11-də diaqnoz kvalifikatorlarla dəqiqləşdirilir: intellektual inkişaf pozuntusu ilə və ya olmadan; funksional dilin pozulması (yoxdur, yüngül-orta, ağır); əvvəllər qazanılmış bacarıqların itirilməsi ilə və ya itirilmədən.

2. Tarixçə

- Kanner L. (1943) — «erkən uşaqlıq autizmi» — 11 uşaqda sosial izolyasiya, dəyişikliyə müqavimət, dil pozuntuları müşahidə etmişdir.
- Asperger H. (1944) — «autistik psixopatiya» — normal intellekt və dil ilə sosial qarşılıqlı əlaqə defisitlərini təsvir etmişdir. (Asperger-in nasist rejimi ilə əməkdaşlıq tarixi son onilliklərdə üzə çıxmışdır — Czech H. Mol Autism 2018.)
- Wing L., Gould J. (1979) — «autizm spektri» konsepsiyası; «pozuntular üçlüyü» — sosial qarşılıqlı əlaqə, ünsiyyət, təxəyyül/davranış.
- DSM-III (1980) → DSM-IV (1994): Pervasive Developmental Disorders kateqoriyası — Autistic Disorder, Asperger«s Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, Rett»s Disorder, PDD-NOS ayrı diaqnozlar.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019): bütün alt-tiplər «Autizm Spektri Pozuntusu» tək kateqoriyada birləşdirilmişdir. Əsaslandırma — alt-tiplərin etibarlı və davamlı ayrılmasının sübut bazası zəif idi. DSM-5-də şiddət 3 səviyyəyə bölünür (1 — dəstək tələb edir; 2 — əhəmiyyətli dəstək; 3 — çox əhəmiyyətli dəstək). XBT-11-də şiddət ayrıca kvalifikator deyil — alt-spesifikasiya intellektual və dil pozulması əsasında qurulur.
- Uşaqlıq dezinteqrativ pozuntusu XBT-11-də ayrıca kod kimi verilmir — 6A02 daxilində «əvvəllər qazanılmış bacarıqların itirilməsi» kvalifikatoru ilə təsnif edilir.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: CDC ADDM Network 2023 hesabatı (8 yaşlı uşaqlar, 2020 məlumatı): 1/36 (2,8%) — son onilliklərdə artım qeydə alınmışdır (1/150 — 2000; 1/68 — 2012). Artımın əksər hissəsi diaqnoz meyarlarının genişlənməsi, məlumatlılığın artması və skrininq tətbiqi ilə izah edilir.
- Cins: kişilərdə təxminən 4:1 — lakin qadınlarda diaqnozun az qoyulması problemi sənədləşdirilmişdir (qadın fenotipi — sosial maskalanma, daha az aşkar təkrarlanan davranışlar; Lai M.C., Baron-Cohen S. Lancet Psychiatry 2015).
- İntellektual əlillik komorbidliyi: təxminən 30–40% (ing. CDC ADDM); təxminən 30–35% IQ <70.
- Digər komorbidliklər: DDHP təxminən 30–50%, narahatlıq təxminən 40%, depressiya yeniyetməlikdə təxminən 25%, epilepsiya təxminən 10–30% (yaşla artır), yuxu pozuntuları 50–80%, qidalanma problemləri, mədə-bağırsaq traktı şikayətləri.

- Ölüm göstəricisi: əhali ilə müqayisədə 2 dəfə artmışdır — əsas səbəblər: epilepsiya, qəzalar (suda boğulma, itkin düşmə halları), intihar (yüksək funksiyalı ASP-də).

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər (50–80% irsilik)

- İrsilik: Sandin S. və b. JAMA 2017 İsveç qardaşları və əkiz tədqiqatı n > 2 milyon: irsilik təxminən 80%; mühit faktorlarının payı təxminən 20%.
- Genetik sindromlarla əlaqə: Fragile X (təxminən 2–5% ASP hallarının), Rett sindromu (qadınlarda demək olar həmişə MECP2 mutasiyası), tuberoz skleroz (təxminən 1–4%), 22q11.2 delesiya, 16p11.2, Phelan-McDermid (22q13).
- De novo CNV və SNV mutasiyaları — təxminən 25% hallarda müəyyən edilir; sinaptik genlər (SHANK3, NRXN1, NLGN3/4, CHD8, SCN2A) qeyd edilir (Satterstrom F.K. və b. Cell 2020 — 102 risk geni).
- Poliqen risk quruluşu — sayca yüzlərlə kiçik təsirli variant; tək gen «autizm geni» yoxdur.
- Ata yaşı 40-dan çox olduqda yeni mutasiya riski artır.

4.2 Prenatal və perinatal risk amilləri

- Ananın hamiləlik dövründə valproat istifadəsi — autizm spektri pozuntusu riskini təxminən 2,9 dəfə (95% CI 1,7–4,9), uşaq autizmi riskini təxminən 5,2 dəfə (95% CI 2,7–10,0) artırır; mütləq risk 4,42% və 2,50% (əhalidə 1,53% və 0,48%) — Christensen J. və b. JAMA 2013; FDA və EMA xəbərdarlığı.
- Vaxtından əvvəl doğuluş — 22–27 həftədə riski təxminən 3,7–4,2 dəfə (Crump C. və b. Pediatrics 2021), 22–31 həftədə təxminən 2,3 dəfə (Persson M. və b. PLOS Med 2020) artırır; erkən doğulmuşlarda ASP-nin yayılması 7% (95% CI 4–9), median gestasiya 28 həftə (Agrawal S. və b. Pediatrics 2018).
- Aşağı doğum kütləsi, perinatal hipoksiya.
- Anada diabet, ağır piylənmə və hamiləlik hipertenziyası — risk amilləri kimi göstərilir.
- Hamiləlik dövründə anada virus infeksiyaları (məxmərək, sitomeqalovirus) yüksək risk yaradır.

4.3 Neyrobioloji mexanizmlər

- Erkən beyin böyüməsində qeyri-tipik model — 2–4 yaşda sürətlənmə, sonra normalizasiya (Courchesne E. və b. JAMA 2003).
- Sinaptik formalaşma və budanma proseslərində tənzimlənmənin pozulması — həyəcanlandırıcı və inhibitor balanssızlıq.
- Beynin sahələrarası funksional əlaqəsində qeyri-tipik model — yerli həddən artıq bağlantı, uzaqmənzilli zəif bağlantı (Just M.A. və b. Brain 2004; sonradan qarışıq sübutlar).
- Sosial koqnisiya şəbəkəsi (medial prefrontal qabıq, temporal-parietal qovşaq, amigdala) və güzgü neyron sistemi qeyri-tipik aktivasiya modelləri göstərir.

4.4 Ətraf mühitlə bağlı risk amilləri

- Hava çirkliliyi (PM2,5, NO_2) hamiləlik və erkən uşaqlıqda — riski mülayim dərəcədə artırır (Volk H.E. və b. JAMA Psychiatry 2013).
- Anada folat çatışmazlığı (konsepsiyadan əvvəlki və sonrakı dövrdə) — folat əlavələri ilə risk azalır (Surén P. və b. JAMA 2013).

5. Klinik təzahürlər

5.1 Sosial ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqə çatışmazlıq

- Qarşılıqlı sosial-emosional mübadilədə çatışmazlıq — qeyri-tipik sosial yaxınlıq, qarşılıqlı söhbətin azalması, paylaşılan maraqların məhdudluğu.
- Qeyri-verbal kommunikativ davranış çatışmazlıq — göz təmasının qeyri-tipik istifadəsi, jest və mimika koordinasiyasının azlığı.
- Münasibətlərin formalaşdırılması və qorunmasında çətinlik — yaşa uyğun dostluqların azlığı, xəyali oyunların azlığı.

5.2 Məhdud, təkrarlanan davranış modelləri

- Stereotipik və ya təkrarlanan motor hərəkətlər, əşyaların istifadəsi və ya nitq (exolaliya, idiosinkratik ifadələr).
- Eyniliyə təkid etmə, rutinlərə davamlı bağlılıq və ya ritualizə olunmuş davranış (geyim, qida, marşrut).
- Yüksək intensivlikli və ya fokuslanmış məhdud maraqlar (xüsusi mövzuya kompleks bilik — «intensiv məhdud maraq»).
- Sensor giriş üçün qeyri-tipik reaktivlik — hiperreaktivlik (səs, toxunma), hiporeaktivlik (ağrı) və ya qeyri-tipik sensor maraqları (səthlərin yoxlanması, vizual stimullaşdırma).

5.3 İnkişaf gedişatı

Erkən əlamətlər — sosial diqqətin azlığı, ad çağırışına cavab verməmə, qarşılıqlı təbəssümün olmaması, qeyri-verbal ünsiyyət (12–18 ay). Uşaqların bir hissəsində inkişaf reqressiyası (qazanılmış dil və sosial bacarıqların 12–24 ayda itirilməsi) qeydə alınır — təxminən 30% hallar (CDC).

Yetkinlikdə — qadınlarda və yüksək funksiyalı şəxslərdə sosial maskalanma (masking) (Hull L. və b. J Autism Dev Disord 2017) çətinlikləri gizlətmək tükənməyə və ikincili psixiatrik komorbidliyə (narahatlıq, depressiya) səbəb olur.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11, NICE CG170 konsensus nöqtələri)

A. Sosial ünsiyyət və sosial qarşılıqlı əlaqədə davamlı çatışmazlıq — aşağıdakı üç sahənin hamısında:

6. Sosial-emosional qarşılıqlı mübadilə;
7. Sosial qarşılıqlı əlaqədə qeyri-verbal kommunikativ davranış;
8. Münasibətlərin inkişafı, qorunması, başa düşülməsi.

B. Məhdud, təkrarlanan davranış, maraq və ya fəaliyyət modelləri — aşağıdakı dördündən ən azı ikisi:

4. Stereotipik və ya təkrarlanan motor hərəkətlər, əşya istifadəsi, nitq;
5. Eyniliyə təkidlilik, rutinə bağlılıq, ritualizə olunmuş davranış və ya nitq;
6. Yüksək intensivlikli, fokuslanmış məhdud maraqlar;
7. Sensor giriş üçün hiper- və ya hiporeaktivlik və ya qeyri-tipik sensor maraqları.

C. Simptomlar erkən inkişaf dövründə mövcud olmalıdır (sosial tələblər artana qədər tam görünməyə bilər).

D. Funksional pozulma — sosial, akademik və ya başqa vacib sahələrdə.

E. İstisnalar — intellektual inkişaf pozuntusu və ya qlobal inkişaf gecikməsi ilə tam izah olunmur (komorbidlik mümkündür).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR (F84.0): üç şiddət səviyyəsi (1–3) hər iki sahə üçün ayrı təyin olunur — dəstək tələbinin intensivliyinə görə. Dəqiqləşdirici əlamətlər: intellektual inkişaf pozuntusu, dil pozuntusu, məlum tibbi/genetik vəziyyət, başqa neyroinkişaf pozuntusu, katatoniya ilə.

- XBT-11 (6A02): alt növlər — intellektual inkişaf pozuntusu olmadan (6A02.0/.2) / ilə (6A02.1/.3); funksional dilin pozulma dərəcəsi (yox / yüngül-orta / ağır). DSM-dəki 1–3 şiddət sistemi rəsmən qəbul edilməmişdir.
- NICE CG170 («19 yaşadək autizm spektri pozuntusu: dəstək və idarəetmə», 2013): diaqnoz multidissiplinar qrup tərəfindən (pediatr / psixiatr + nitq-dil patoloqu + klinik psixoloq) qoyulmalıdır; ADOS-2 və ADI-R diaqnostik qızıl standart hesab edilir.
- Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) 2020 (Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M. Pediatrics 2020;145(1)): 18 və 24 ayda universal autizm skrininq tövsiyə edilir (M-CHAT-R/F); müsbət skrininq nəticəsi müsbət olduqda mütəxəssis qiymətləndirməsi təyin edilir.
- AACAP Practice Parameter (Volkmar F. və b. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014): diaqnostika alqoritmi, komorbidlik qiymətləndirməsi, müalicə tövsiyələri.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

3. Valideynlərlə və qayğı göstərən şəxslərlə müsahibə — inkişaf tarixçəsi, erkən sosial və kommunikativ əlamətlər.
4. Skrininq: 18 və 24 ay (M-CHAT-R/F); müsbət olduqda təkrar skrininq aparılır.
5. Mütəxəssis qiymətləndirməsi — pediatr / inkişaf pediatrı / psixiatr / klinik psixoloq.
6. Qızıl standart diaqnostik vasitələr: ADOS-2 (ing. Autism Diagnostic Observation Schedule) — oyun əsaslı strukturlaşdırılmış müşahidə; ADI-R (ing. Autism Diagnostic Interview, Revised) — valideyn müsahibəsi.
7. İntellektual qiymətləndirmə (WISC-V, Stanford-Binet 5, qeyri-verbal seçimlər — Leiter-3, Mullen).
8. Nitq-dil və adaptiv davranış qiymətləndirməsi (Vineland-3).
9. Eşitmə və görmə testləri.
10. Tibbi və genetik qiymətləndirmə — xromosom mikroarray (CMA — chromosomal microarray), kövrək X sindromu (Fragile X, FMR1), seçici trio ekzom; epileptik tutma şübhəsi olduqda elektroensefaloqrafiya (EEQ); klinik şübhədə MRT (mikrosefaliya, reqressiya).
11. Komorbidlik skrininq: DDHP, narahatlıq, depressiya, OKP, yuxu, qida, mədə-bağırsaq traktı (MBT).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
İntellektual inkişaf pozuntusu (6A00)	Ümumi koqnitiv çatışmazlıq; sosial qarşılıqlı əlaqə intellektual səviyyəyə uyğundur. Komorbid ola bilər.
Dilin inkişaf pozuntusu — praqmatik (6A01.22)	Sosial dilin istifadəsində çatışmazlıq; məhdud-təkrarlanan davranış modelləri yoxdur.
Reaktiv bağlanma pozuntusu (6B44)	Erkən psixososial deprivasiyadan yaranır; uyğun mühitdə bərpa potensialı.
Şizotipik pozuntu (6A22)	Adətən yetkinlikdə özünü göstərir; psixozabənzər təfəkkür.
OKP (6B20)	Eqodistonik obsessiyalar və kompulsiyalar; ASP-də ritualar eqosintonikdir.
Sosial narahatlıq pozuntusu (6B04)	Sosial qaçınma narahatlıq əsaslıdır; sosial maraq saxlanılır.
Selektiv mutizm (6B06)	Müəyyən kontekstdə danışmama; ev kontekstində normal nitq.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik diaqnostik vasitələr

- Skrininq: M-CHAT-R/F (16–30 ay), SCQ (Sosial ünsiyyət Sorğusu; 4+ yaş, valideyn doldurur), SRS-2 (ing. Social Responsiveness Scale).
- Diaqnostik: ADOS-2 (kiçik yaşlı uşaqlardan yetkinlərə qədər modullar), ADI-R (1,5+ yaş, valideyn).
- İntellekt və idrak funksiyaları: Mullen Scales of Early Learning, Bayley-III/IV (kiçik yaş), WISC-V, Leiter-3 (qeyri-verbal).
- Adaptiv davranış: Vineland-3, ABAS-3.
- Nitq-dil: PLS-5, CELF-5, CCC-2 (praqmatik).
- Sensor profil: Sensory Profile-2 (Dunn).
- Komorbidlik: DDHP üçün Conners, narahatlıq üçün Uşaq Narahatlıq Ekranı (SCARED), depressiya üçün yeniyetmələrə uyğunlaşdırılmış PHQ-A.

7.2 Laborator müayinələr

Birinci sıra (AAP 2020 / AACAP 2014): chromosomal microarray analysis (CMA — diaqnostik səmərə təxminən 10–20%); Fragile X (FMR1).

Seçici: trio ekzomun ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi (WES — CMA mənfi olduqda diaqnostik səmərə 25–40%); MECP2 (Rett şübhəsi qadınlarda); metabolik (laktat, amonyak, amin turşuları — reqressiya olduqda); qurğuşun səviyyəsi; tiroid stimullaşdırıcı hormon (TSH).

7.3 İnstrumental müayinələr

- EEQ — tutma, reqressiya, qeyri-adi davranış epizodları olduqda.
- Beyin MRT — fokal nevroloji əlamətlər, mikro/makrosefaliya, reqressiya.
- Eşitmə testi — bütün hallarda mütləq (audiometriya, ABR).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG170, AAP 2020, AACAP 2014 konsensus)

6. ASP «müalicə» oluna bilmir — fərdi inkişaf, adaptasiya və həyat keyfiyyəti yaxşılaşdırılır. «Müalicə» və «tam bərpa» iddiası elmi əsaslı deyil; məqsəd funksional bacarıqların, ünsiyyətnın, müstəqilliyin və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır.
7. Erkən, intensiv, fərdi davranış müdaxiləsi birinci sıra metodudur — ən böyük təsir 18 ay–6 yaş aralığında effekt ən böyükdür (Reichow B. və b. Cochrane 2018, EIBI/ESDM meta-analizi).
8. Naturalist İnkişaf və Davranış Müdaxilələri (NİDM / NDBI — Naturalistic Developmental Behavioral Interventions) — uşağın oyun və gündəlik kontekstində davranış-inkişaf prinsipləri əsasında; Tətbiqi Davranış Analizinin (TDA) klassik diskret cəhd formatından daha çevikdir. Bu qrupa daxildir:
    - Erkən Başlanğıc Denver Modeli (ing. Early Start Denver Model, ESDM)
    - Birgə Diqqət, Simvolik Oyun, Cəlb Olunma və Tənzimləmə (JASPER)
    - Açar Reaksiya Terapiyası (ART / PRT)
    - Gücləndirilmiş Mühit Təlimi (ing. EMT — Enhanced Milieu Teaching)
    - Uşaq Autizmində ünsiyyət Terapiyası (ing. UAKT / PACT — Paediatric Autism Communication Therapy)

Metodların ətraflı təsviri «Müalicə metodikaları» bölməsində verilmişdir.

9. Valideyn-koordinasiyalı (parent-mediated) yanaşma — Hanen «More Than Words», PACT (Pickles A., Green J. və b. Lancet 2010, 2016 izləmə — 6 illik effekt davam edir), PRT valideyn versiyası. Resurs məhdud şəraitdə ən sərfəli yanaşmadır.
10. Sosial bacarıq qrupları — böyük yaşlı uşaqlar və yeniyetmələr üçün; PEERS proqramı (UCLA, Laugeson E.A.) yetkin şəxslərdə də effektivliyi sübut edilmişdir.
11. Strukturlaşdırılmış təhsil mühiti — TEACCH modeli (ətraflı təsvir üçün 8.2-ci bölməyə bax) (ing. Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children, Schopler E. North Carolina); fərdi təhsil planı (IEP / EHCP)
12. ünsiyyət dəstəyi — nitqi minimal olan pasiyentlərdə alternativ və artırıcı ünsiyyət (ing. Augmentative and Alternative Communication, AAC) — PECS (ing. Picture Exchange Communication System), nitq cihazları, planşet əsaslı tətbiqlər.
13. Komorbidlik müalicəsi — DDHP (stimulyantlar, Cortese 2018), narahatlıq (KDT modifikasiya — Storch E.A. RKİ-ləri), depressiya (KDT, SSGİ), epilepsiya (standart antiepileptik), yuxu (yuxu gigiyenası, melatonin — RKİ sübutu Goldman S.E. J Clin Sleep Med 2014).
14. Farmakoterapiya yalnız komorbid simptomlar üçün — ASP-nin əsas (nüvə) simptomları üçün FDA tərəfindən təsdiqlənmiş dərman yoxdur. Aqressiv davranış və qıcıqlanma üçün — risperidon (5–16 yaş, FDA təsdiqi 2006) və aripiprazol (6–17 yaş, FDA təsdiqi 2009). Hər ikisi sübutludur (McCracken J.T. və b. NEJM 2002 RKİ — risperidon), lakin yan təsir yükü əhəmiyyətlidir (metabolik, EKPS). Davranış müdaxiləsi birinci sıra metodudur.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Tətbiqi Davranış Analizi (ing. TDA / ABA — Applied Behavior Analysis) — Davranış prinsipləri əsasında öyrənmə metodu; sosial, kommunikativ və adaptiv bacarıqların formalaşdırılması, çətin davranışın azaldılması. Diskret cəhd təlimi (ing. DKT / DTT — Discrete Trial Training) və ya naturalistik formatda tətbiq olunur. Yetkin ASP icmasının bir hissəsi TDA-nın klassik formasını tənqid edir (muxtariyyət, emosional yüklənmə).
2. Erkən İntensiv Davranış Müdaxiləsi (ing. EİDM / EIBI — Early Intensive Behavioral Intervention) — TDA əsasında erkən yaşda strukturlaşdırılmış intensiv müdaxilə (həftədə 25–40 saat); hədəf — sosial, kommunikativ və adaptiv bacarıqlar. Sübut: Reichow B., Hume K., Barton E.E., Boyd B.A.

Cochrane 2018 — İQ, dil və adaptiv davranışda kiçik və orta səviyyəli təsir; mövcud iddialara ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.

3. Erkən Başlanğıc Denver Modeli (ing. EBDM / ESDM — Early Start Denver Model) — Rogers S. və Dawson G. — 12–48 ay üçün naturalistik inkişaf-davranış müdaxiləsi; oyun və gündəlik aktivliklər kontekstində öyrənmə. Sübut: Dawson G. və b. Pediatrics 2010 RKİ n=48 — IQ, dil və adaptiv davranışda əhəmiyyətli irəliləyiş, 6 yaşda diaqnoz dəyişikliyi (Dawson G. və b. JAACAP 2012 izləmə). Valideyn versiyası (P-ESDM) Rogers S.J. və b. JAACAP 2012.
4. Birgə Diqqət, Simvolik Oyun, Cəlbolunma və Tənzimləmə (ing. JASPER — Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, Regulation) Kasari C. — Birgə diqqət və simvolik oyunun inkişafına yönəlmiş müdaxilə; 12–60 ay. Sübut: Kasari C. və b. JAMA Pediatr 2014, J Consult Clin Psychol 2010 — birgə diqqət və ifadəli dildə əhəmiyyətli irəliləyiş.
5. Uşaq Autizmində ünsiyyət Terapiyası (ing. UAKT / PACT — Paediatric Autism Communication Therapy) — Pikls (Pickles A.), Qrin (Green J.) — Valideyn-koordinasiyalı ünsiyyət müdaxiləsi; 2–11 yaş. Valideyn-uşaq qarşılıqlı təsirinin video-əsaslı analizi və genişləndirilməsi. Sübut: Pickles A. və b. Lancet 2016 — n=152, 6 il izləmə — autizm şiddət və valideyn-uşaq qarşılıqlı təsirinin sinxronluğunda davamlı yaxşılaşma. Resurs məhdud şəraitdə də uyğunlaşdırılır.
6. Açar Reaksiya Terapiyası (ing. ART / PRT — Pivotal Response Treatment) — Kogel (Koegel R.L., Koegel L.K.) — əsas (pivotal) davranışlara fokuslanma (motivasiya, çoxsaylı stimula cavab, özünüidarə, özünə başlama) — bunlar öyrənildikdə dəyişiklik çoxlu sahələrə yayılır. Metod naturalist formatda, uşağın seçimləri əsasında tətbiq olunur.
7. Autizmli və ünsiyyət Çətinliyi Olan Uşaqların Müalicəsi və Təhsili (ing. Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children, TEACCH) — Şopler (Schopler E.) — Strukturlaşdırılmış vizual təhsil mühiti — «strukturlaşdırılmış tədris» — vizual cədvəl, iş sistemləri, fərdi keçidlər; ev, məktəb və icma kontekstində. North Carolina mənşəli, dünyaya yayılmışdır.
8. Şəkil Mübadiləsi ilə ünsiyyət Sistemi (ing. ŞMKS / PECS — Picture Exchange Communication System) — Bondy A. və Frost L. — Minimal verbal pasiyentlər üçün şəkil mübadiləsi əsaslı ünsiyyət təlimi — 6 mərhələdə. Sübut: Howlin P. və b. J Child Psychol Psychiatry 2007 RKİ — ünsiyyətda artma.
9. Münasibət Bacarıqlarının Öyrədilməsi və Zənginləşdirilməsi Proqramı (ing. Program for the Education and Enrichment of Relational Skills, PEERS) — Loqeson (Laugeson E.A., UCLA) — Yeniyetmələr və gənc yetkin ASP-li

şəxslər üçün strukturlaşdırılmış sosial bacarıq qrupu; 16 həftə, valideyn dəstəyi ilə. Sübut: Laugeson E.A. və b. J Autism Dev Disord 2012, 2015.

10. Hanen proqramı «More Than Words» («Sözdən çox») — 2–5 yaşlı ASP-li uşaqların valideynləri üçün 8 qrup seansı və 3 fərdi ev ziyarəti («Hanen» proqramının rəsmi saytı: hanen.org).
11. ÜST-ün Qayğı Göstərən Şəxslərin Bacarıqları Təlimi (ing. QGŞBT / CST — WHO Caregiver Skills Training) ÜST-ün aşağı və orta gəlirli ölkələr üçün məhdud resurslu valideyn təlimi; ASP və inkişaf gecikmələri üçün; icmada işləyən qeyri-mütəxəssis təlimatçılar tərəfindən tətbiq edilir.
12. EEQ neyrobioidarəetmə (EEG neurofeedback) — 8.2-də yalnız qısa istinad verilməli, tam təsvir 10.3-cü bölmədə saxlanmalıdır. istifadəçinin öz beyin aktivliyini tənzimləməsinə yönəlmiş təlim. ASP-də əsas simptomlara təsir bazası məhduddur; Holtmann M. və b. Dev Med Child Neurol 2011 — DDHP-də cüzi təsir, ASP-də isə xüsusi sübut zəifdir. Birinci sıra metodu deyil, köməkçi metod statusundadır; pasiyent və ailəyə sübut bazasının məhdudluğu izah edilməlidir.
13. Autizm Diaqnostik Müşahidə Şkalası (ing. ADOS-2 — Autism Diagnostic Observation Schedule) və Autizm Diaqnostik Müsahibəsi (ing. ADM / ADI-R — Autism Diagnostic Interview-Revised) — Diaqnostik qızıl standart vasitələri — ADOS-2 strukturlaşdırılmış oyun-əsaslı müşahidə (5 modul, kiçik yaşlılardan yetkinlərə qədər); ADI-R standartlaşdırılmış valideyn müsahibəsi (1,5+ yaş, təxminən 2 saat).

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG170 (2013, 2021 yenilənmə): diaqnostika multidissiplinar qrup tərəfindən; sosial ünsiyyət müdaxilələri birinci sıra sayılır; valideyn proqramları üstün tutulur; antipsixotik yalnız davranış müdaxilə uğursuz olduqda; əsassız «tam müalicə» iddialarına qarşı xəbərdarlıq edilir.
- AAP Clinical Report 2020 (Hyman və b.): 18 və 24 ayda universal skrininq, 3 yaşdan kiçiklər üçün erkən müdaxilə tövsiyə edilir; inteqrasiya olunmuş tibbi və davranış müdaxiləsi.
- AACAP Practice Parameter 2014 (Volkmar): diaqnoza uyğun təhsil yerləşdirilməsi, komorbidlik müalicəsi, ailə dəstəyi vurğusu.
- ÜST-ün Qayğı Göstərən Şəxslərin Bacarıqları Təlimi (QGŞBT / CST): aşağı və orta gəlirli ölkələr üçün məhdud resurslu valideyn təlimi proqramı; çoxlu ölkədə uyğunlaşdırılır (Salomone E. və b. Autism 2019).

9. Proqnoz

9.1 Yaxşı proqnoz amilləri

- Erkən diaqnoz (<3 yaş) və erkən intensiv müdaxilə.
- İntellektual funksiyanın saxlanılması (İQ >70).
- 5 yaşa qədər funksional dilin əldə edilməsi.
- Komorbid pozuntuların idarə edilməsi.
- Stabil ailə dəstəyi və icma resursları.

Pis proqnoz amilləri

- Komorbid intellektual inkişaf pozuntusu (ağır və ya dərin).
- 5 yaşa qədər funksional dilin olmaması.
- Epileptik tutmalar yetkinlik dövründə əlavə risk yaradır.
- Ağır davranış pozuntuları, özünə zərər.
- Diaqnoz və müdaxilənin gec başlanması.

9.3 İzləmə hədəfləri

- Komorbid psixiatrik vəziyyətlər (DDHP, narahatlıq, depressiya, OKP) hər il skrininq aparılmalıdır.
- Epilepsiya monitorinqi — xüsusilə yeniyetməlik dövründə.
- Yuxu, qida, mədə-bağırsaq traktı və motor pozuntuları üzrə skrininq aparılmalıdır.
- Yetkinliyə keçid planlaması (16–18 yaş) — peşə, müstəqil yaşayış, məşğulluq.
- Yetkin pasiyentlərdə sosial kamuflyajın emosional yükü, narahatlıq və depressiya — aktiv skrininq.
- Ailə üçün fasilə (respite) dəstəyi, həmyaşıd dəstəyi, psixoedukasiya.
- Neyrodiversiya yanaşması — pasiyentin güclü tərəflərinə əsaslanmaq; «tam müalicə» iddiası yoxdur.

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «Peyvəndlər (xüsusilə qızılca-parotit-rubella — MMR) autizmə səbəb olur»

Niyə yayılıb: Wakefield A.J. və b. Lancet 1998 — 12 uşaq əsasında MMR peyvəndini bağırsaq pozuntusu və autizmlə əlaqələndirdiyini iddia etmişdi. Sonradan Brian Deer-in jurnalist tədqiqatları və General Medical Council araşdırması — Wakefield-in maliyyə marağı və məlumatların manipulyasiyası aşkar edildi; məqalə 2010-cu ildə tam geri çəkildi; Wakefield həkimlikdən məhrum edildi.

Klinik və bioloji məntiq: autizm 12–18 ayda klinik təzahür edir — MMR peyvəndinin tətbiqi vaxtı ilə simptomların ilk təzahürü arasındakı zaman uyğunluğu yanlış «səbəb» kimi qavranıla bilər. Patogenez genetik və erkən neyroinkişaf əsaslıdır (irsilik 80%, prenatal və perinatal faktorlar) — peyvənddən asılı deyil.

Sübut: Taylor L.E., Swerdfeger A.L., Eslick G.D. Vaccine 2014 meta-analiz 1,2 milyondan çox uşaq — MMR ilə autizm arasında əlaqə yoxdur; Madsen K.M. və b. NEJM 2002 Danimarka tədqiqatı n>537 000; Jain A. və b. JAMA 2015 ABŞ tədqiqatı. CDC, WHO, NICE, AAP eyni mövqedədir.

Praktik klinik addım: ailəyə sübutları sakit və hörmətli tonda təqdim et; peyvənddən imtina etməsinin uşaq və icma sağlamlığı üçün yaratdığı riski izah et (Madagaskarda 2018–2019 qızılca epidemiyası 1200-dən çox uşaq ölümü).

Mif 2: «Mikroplastik, ağır metallar, kimyəvi qida əlavələri autizmin əsas səbəbidir»

Niyə yayılıb: «təbii / kimyəvi maddəsiz» hərəkatının kütləvi mediada şişirdilmiş təqdimatı; mikroplastiklərlə bağlı tədqiqatların kontekstdən kənar istifadəsi.

Klinik və bioloji məntiq: autizmin əsas etiologiyası genetikdir (irsilik 80% — Sandin JAMA 2017). Ətraf mühit amilləri risk amili kimi tədqiq edilir ($PM_{2.5}$ hava çirklənməsi — Volk JAMA Psychiatry 2013; valproat prenatal — Christensen JAMA 2013), lakin «əsas səbəb» kimi mikroplastik və ya ağır metallar üçün sübut bazası yoxdur.

Sübut: Hertz-Picciotto I. Environ Health Perspect 2018 icmal — bəzi neyrotoksinlər (xüsusilə valproat, alkohol) risk amili kimi qəbul edilir; ağır metallara ekspozisiya (məruz qalma) birbaşa autizm etiologiyası kimi sübut edilməyib.

Real klinik addım: ailəyə faktiki risk amillərini (valproat hamiləlikdə, hava çirklənməsinin məhdudlaşdırılması) və qoruyucu addımları göstər (konsepsiyadan əvvəlki dövrdə folat qəbulu) istiqamətləndir.

Mif 3: «Soyuducu ana» (Bettelheim — «Refrigerator Mother» nəzəriyyəsi)

Niyə yayılıb: Bruno Bettelheim 1967 «The Empty Fortress» əsərində autizmi anaların emosional soyuqluğuna bağladı; 1970-ci illərə qədər üstünlük təşkil edən inanc.

Klinik və bioloji məntiq: autizm neyroinkişaf pozuntusudur — genetik və erkən beyin inkişafı ilə bağlıdır; valideyn davranışı autizm yaratmır.

Sübut: Rimland B. (1964) «Infantile Autism» — bioloji etiologiya argumenti; Folstein S., Rutter M. Nature 1977 — əkiz tədqiqatı genetik irsiliyi sübut etdi. APA, AAP, AACAP — «soyuq ana» konsepsiyası ləğv edilmişdir.

Real klinik addım: ailəyə günahlandırma əvəzinə dəstək və psixoedukasiya; valideyn-koordinasiyalı müdaxilələr (PACT, ESDM, Hanen).

10.2 Zərərli və ya təhlükəli «müalicə» üsulları

Mif 4: «Xelat terapiyası ağır metalları çıxararaq autizmi sağaldır»

Niyə yayılıb: «ağır metal autizmi» yanlış nəzəriyyəsi; alternativ klinikaların aqressiv reklamı.

Sübut və risk: AAP 2010 və FDA xəbərdarlığı — 5 yaşlı uşaq xelasiya proseduru zamanı kalsium çatışmazlığı səbəbindən ürək dayanmasından vəfat etmişdir (2005). Xelasiya yalnız təsdiqlənmiş ağır metal zəhərlənməsində (yüksək qurğuşun) göstərişdir, autizm üçün yox. AAP və AACAP bunu mütləq əksgöstəriş hesab edir.

Mif 5: «Hiperbarik oksigen kamerası (HBOT) autizmi sağaldır»

Sübut: Cochrane (Xiong T. və b. 2016) n=1 RKİ icmal — autizm üçün effekt sübutu yoxdur. Risklər: pnevmotoraks, qulaq barotravması, yanğın təhlükəsi (oksigen və statik elektrik).

Mif 6: «MMS / „Mineral Məhlul“ (klor dioksid) autizmi sağaldır»

Sübut: FDA 2019, EMA xəbərdarlıqları — xlor dioksid kostikdir, qaraciyər və böyrək zədəsi, ölüm halları qeydə alınmışdır. Bütün klinik istifadə qadağandır. Xüsusilə təhlükəlisi, anus yolu ilə təmizləyici vasitə kimi tövsiyə edilən «müalicə» uşaqlara qarşı zorakılıqdır.

Mif 7: «Kök hüceyrə inyeksiyaları autizmi sağaldır»

Sübut: Beynəlxalq Kök Hüceyrə Tədqiqatları Cəmiyyəti (ISSCR) və FDA — autizm üçün təsdiqlənmiş kök hüceyrə müalicəsi yoxdur. Qeyri-qanuni klinikalarda — infeksiyalar, beyin şişləri, ölüm halları qeydə alınmışdır (Berkowitz NEJM 2016).

Mif 8: «Çelyabinsk dərmanı» və oxşar tibbi nəzarəti olmayan dərmanlar

Sübut: heç bir tənzimləyici orqan (FDA, EMA, Avropa İttifaqı) tərəfindən autizm müalicəsi kimi təsdiqlənməmişdir; risk yüksəkdir, fayda sübut edilməmişdir.

10.3 Səmərəsiz və ya əsas müdaxiləni təxirə salan üsullar

Mif 9: «Dəstəklənmiş kommunikasiya (FC) və sürətli göstəriş metodu (RPM) nitqi minimal olan autizmli şəxslərin daxili dünyasını üzə çıxarır»

Niyə yayılıb: emosional cəlbedici hekayələr — fasilitatorun köməyi ilə «danışmağa başlayan» uşaqlar.

Sübut: ASHA Position Statement 2018 (yenilənmə): müstəqil yoxlamalar göstərmişdir ki, mesajlar pasiyentdən deyil, fasilitatordan gəlir (ideomotor effekt). Bu sübut çoxlu RKİ-də təsdiqlənib (ing. Schlosser R.W. və b. Augment Altern Commun 2014). Klinik nəticə: ailə üçün yanlış inanc; pasiyentin həqiqi ünsiyyətsı (PECS, AAC cihazları) gecikdirilir; ictimai zərər — hüquqi problemlərdə yalandan «şəhadət» hadisələri.

Real klinik addım: minimal verbal pasiyentlər üçün sübutlu AAC vasitələri — PECS, planşet əsaslı ünsiyyət proqramları (Proloquo2Go, TouchChat).

Mif 10: «Qlutensiz / kazeinsiz pəhriz autizmi sağaldır və ya əhəmiyyətli yaxşılaşdırır»

Sübut: Hyman S.L. və b. (AAP 2020 Clinical Report) — autizm simptomlarına xüsusi pəhrizlərin təsiri sübut edilməmişdir; qarın-bağırsaq simptomu və ya çölyak xəstəliyi (seliak) varsa pəhriz tibbi göstərişdir. Geniş pəhriz məhdudiyyəti uşaqlarda qida çatışmazlıqlarına və yemək davranışı pozuntularına səbəb olur. Karagas M.R. və b. JAMA Pediatr 2018 — geniş pəhriz məhdudiyyətinin riskləri.

Mif 11: «EEG Neyrofidbek autizmin əsas simptomlarını sağaldır»

Sübut: Holtmann M. və b. Dev Med Child Neurol 2011 icmal — DDHP-də təvazökar effekt; autizm üçün spesifik sübut zəif. Adjunkt status, birinci sıra deyil. Pasiyent və ailəyə açıq izah edilməlidir.

Mif 12: «Eşitmə inteqrasiyası təlimi (ing. Auditory Integration Training, AIT) autizmi sağaldır»

Sübut: ASHA-nın 2004-cü il bəyanatı və AAP-ın 1998-ci il açıqlaması bu metodu eksperimental statusda qiymətləndirir; effekt sübutu yoxdur.

Mif 13: «Vitamin B6 / maqnezium və ya digər mega-doza vitamin terapiyası»

Sübut: Cochrane (Nye C., Brice A. 2005) — B6/maqnezium kombinasiyasının autizm üçün effekti sübut edilməyib. Yüksək dozalarda vitamin qəbulu yan təsirlərə (B6 neyropatiyası) gətirə bilər.

Mif 14: «Nümunələmə metodu» (patterning; Doman-Delakato)

Sübut: AAP-ın 1968 və 2010-cu il bəyanatları — effekt sübutu yoxdur, ailəyə həddən artıq zəhmət; uşaqları sübutlu müdaxilələrdən məhrum edir.

Mif 15: «Kraniosakral terapiya, refleksoterapiya, homeopatiya»

Sübut: sistemli icmallar (Cochrane və başqaları) — autizm üçün effekt sübutu yoxdur. NICE CG170 — köməkçi metodlara qarşı xəbərdarlıq edir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və xəstəlik statistikası üzrə Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A02 Autizm spektr pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təsnifatı (DSM-5-TR). Vaşinqton: APA Publishing; 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik Təlimat 170. 19 yaşdan kiçiklərdə autizm spektr pozuntusu: dəstək və idarəetmə. 2013, 2021-ci il yenilənməsi.
4. Hayman S.L., Levi S.E., Mayers S.M.; Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) Əlilliyi olan Uşaqlar üzrə Şurası. Autizm spektr pozuntusu olan uşaqların müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. «Pediatriya» (Pediatrics). 2020;145(1):e20193447.
5. Volkmar F., Sigel M., Vudberi-Smit M., Kinq B., MakKreken C., Steyt M. Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının (AACAP) autizm spektr pozuntusu olan uşaqların və yeniyetmələrin qiymətləndirilməsi və müalicəsi üzrə təcrübə parametri. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2014;53(2):237–257.

6. ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi (CDC). 8 yaşlı uşaqlar arasında autizm spektr pozuntusunun yayılması və xüsusiyyətləri — Autizm və İnkişaf Əlilliklərinin Monitorinqi Şəbəkəsi. «Xəstəlik və Ölüm Həftəlik Hesabatı: Nəzarət Xülasələri» (MMWR Surveill Summ). 2023;72(2):1–14.
7. Sandin S., Lixtenşteyn P., Kuya-Halkola R. və b. Autizm spektr pozuntusunun irsiyyəti. «JAMA». 2017;318(12):1182–1184.
8. Satterstrom F.K. və b. Böyük miqyaslı ekzom sekvenləmə tədqiqi autizmin neyrobiologiyasında həm inkişaf, həm də funksional dəyişiklikləri göstərir. «Cell». 2020;180(3):568–584.
9. Teylor L.E., Sverdfeger A.L., Eslick Q.D. Vaksinlər autizmlə əlaqəli deyil: sübuta əsaslanan meta-analiz. «Vaksin» (Vaccine). 2014;32(29):3623–3629.
10. Madsen K.M., Hviid A., Vesterqaard M. və b. Qızılca, parotit və məxmərək peyvəndi ilə autizm arasında əhalinin müşahidinə əsaslanan tədqiqat. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2002;347(19):1477–1482.
11. Kristensen Y., Grønborq T.K., Sørensen M.C. və b. Prenatal valproata məruz qalma və autizm spektr pozuntuları riski. «JAMA». 2013;309(16):1696–1703.
12. Süren P., Rot K., Bresnahan M. və b. Anaların fol turşusu əlavələrindən istifadəsi ilə uşaqlarda autizm spektr pozuntuları riski arasında əlaqə. «JAMA». 2013;309(6):570–577.
13. Volk H.E., Lurmann F., Penfold B. və b. Nəqliyyatla əlaqəli hava çirkliliyi, asılı hissəciklər və autizm. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2013;70(1):71–77.
14. Dawson Q., Rocers S., Munson C. və b. Autizmi olan kiçik uşaqlar üçün müdaxilənin randomizə edilmiş nəzarətli sınağı: Erkən Başlanğıc Denver Modeli. «Pediatriya» (Pediatrics). 2010;125(1):e17–e23.
15. Reyxov B., Hüme K., Barton E.E., Boyd B.A. Autizm spektr pozuntuları (ASD) olan kiçik uşaqlar üçün erkən intensiv davranış müdaxiləsi (EIBI). «Koçreyn Sistemli İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2018;(5):CD009260.
16. Pikls A., Le Kuteur A., Leadbitter K., Salomone E., Koul-Fletçer R., Tobin H., Gammer İ., Louri C., Vamvakas Q., Bayford S., Aldred K., Slonims V., MakKonaçi H., Haulin P., Parr C.R., Çarman T., Qrin C. Valideyn vasitəçiliyi ilə autizmi olan kiçik uşaqlar üçün sosial ünsiyyət terapiyası (PACT): randomizə edilmiş nəzarətli sınağın uzunmüddətli izlənməsi. «Lancet». 2016;388(10059):2501–2509.
17. Kasari C., Gülsrüd A., Paparella T., Hellemann Q., Berri K. Autizmi olan kiçik uşaqlar üçün valideyn vasitəçiliyi müdaxilələrinin randomizə edilmiş

müqayisəli effektivlik tədqiqi. «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 2015;83(3):554–563.

18. MakKreken C.T., MakQaf C., Şah B. və b. Autizmi və ciddi davranış problemləri olan uşaqlarda risperidon. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2002;347(5):314–321.
19. Kşionq T., Çen H., Luo R., Mu D. Autizm spektr pozuntusu olan insanlar üçün hiperbarik oksigen terapiyası. «Koçreyn Sistemli İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2016;(10):CD010922.
20. Amerika Nitq-Dil və Eşitmə Assosiasiyası (ASHA). Mövqe Bəyanatı: Asanlaşdırılmış ünsiyyət. 2018. asha.org/policy/PS2018-00352.
21. Qoldman S.E., Adkins K.V., Kalkatt M.V. və b. Autizm spektr pozuntuları olan uşaqlarda melatonin. «Klinik Yuxu Tibb Jurnalı» (J Clin Sleep Med). 2014;10(8):871–882.
22. Lauqeson E.A., Frankel F., Qantman A., Dillon A.R., Mocil K. Autizm spektr pozuntuları olan yeniyetmələr üçün sübuta əsaslanan sosial bacarıqlar təlimi: UCLA PEERS proqramı. «Autizm və İnkişaf Pozuntuları Jurnalı» (J Autism Dev Disord). 2012;42(6):1025–1036.
23. Lay M.C., Baron-Koen S. Autizm spektr vəziyyətləri olan böyüklərin itirilmiş nəslinin müəyyən edilməsi. «Lancet Psixiatriyası» (Lancet Psychiatry). 2015;2(11):1013–1027.
24. Berkouits A.L., Miller M.B., Mir S.A. və b. «Kök hüceyrə turizmi»nin ağırlaşması kimi onurğa beyninin qlioproliferativ zədələnməsi. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2016;375(2):196–198.
25. Bondi A., Frost L. Şəkil Mübadiləsi Ünsiyyət Sistemi. «Davranış Modifikasiyası» (Behav Modif). 2001;25(5):725–744.
26. Koqel R.L., Koqel L.K. Autizm üçün əsas reaksiya müalicəsi (PRT). Baltimor: Brookes; 2006.
27. Mesibov Q.B., Şea V., Şopler E. Autizm spektr pozuntularına TEACCH yanaşması. Nyu-York: Springer; 2005.
28. Storç E.A., Arnold E.B., Levin A.B. və b. Autizm spektr pozuntusu olan uşaqlarda narahatlıq üzrə koqnitiv-davranış terapiyasının adi müalicə ilə müqayisədə təsiri: randomizə edilmiş nəzarətli sınaq. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2013;52(2):132–142.

XBT-11 **6A03**	**6A03 İNKİŞAF ÖYRƏNMƏ POZUNTUSU** **Developmental learning disorder**
XBT-10 F81	Məktəb bacarıqlarının inkişafının spesifik pozuntuları
DSM-5-TR F81.0	Spesifik öyrənmə pozuntusu, oxu pozulması ilə

1. Tərif və nozologiya

İnkişaf öyrənmə pozuntusu (XBT-11: 6A03 Developmental Learning Disorder; DSM-5-TR: 315.00 Spesifik öyrənmə pozuntusu) — pasiyentin yaşı, intellektual səviyyəsi və təhsil imkanları nəzərə alındıqda gözlənilməyən, akademik bacarıqlardan birinin və ya bir neçəsinin əldə edilməsində davamlı və əhəmiyyətli çətinliklərlə təzahür edən neyroinkişaf pozuntusudur.

XBT-11-də alt kateqoriyalar:

- 6A03.0 — oxuma pozulması ilə (disleksiya);
- 6A03.1 — yazılı ifadə pozulması ilə (disqrafiya);
- 6A03.2 — riyaziyyat pozulması ilə (diskalkuliya);
- 6A03.3 — dəqiqləşdirilməmiş; 6A03.Y — digər spesifikləşdirilmiş.

2. Tarixçə

- Pringle Morgan W. (1896) — «anadangəlmə söz korluğu» (ing. congenital word blindness) — normal intellektə baxmayaraq oxuya bilməyən uşağı təsvir etmişdir.
- Orton S.T. (1925) — «strephosymbolia» konsepsiyası; sol hemisfera dominantlığının zəifliyini fərziyyə irəli sürmüşdür; Orton-Qillinghem metodunun əsasını qoymuşdur.
- DSM-III (1980) — «Spesifik İnkişaf Pozuntusu» kateqoriyası — intellekt əmsalı (IQ) ilə akademik bacarıq arasındakı fərqə əsaslanan (ing. discrepancy model).
- DSM-5 (2013) — diskrepansiya modelinin ləğvi: «Spesifik öyrənmə pozuntusu» (ing. Specific Learning Disorder) — IQ kəsim həddi tələb edilmir; davamlı funksional çətinlik və müdaxiləyə cavabsızlıq əsas

götürülür. Alt tiplər (oxuma, yazma, riyaziyyat) ayrı-ayrı spesifikatorlarla göstərilir.

- XBT-11 (2019) — paralel struktur; «inkişaf öyrənmə pozuntusu» (ing. Developmental Learning Disorder) termini ilə.
- Fonoloji çatışmazlıq nəzəriyyəsi (Stanovich K.E., Snowling M.J., Vellutino F.R.) — disleksiyanın əsas mexanizmi kimi 1990–2000-ci illərdə üstünlük təşkil etmişdir.

3. Epidemiologiya

- Ümumi yayılma: məktəb yaşlı uşaqlarda 5–15% (DSM-5-TR qiymətləndirməsinə görə); ölkə və dilin orfoqrafik dərinliyindən asılı olaraq dəyişir (ingilis dili kimi dərin orfoqrafiyalı dillərdə nisbət yüksəkdir).
- Disleksiya: məktəb yaşlı uşaqlarda 5–10%; ən çox rast gələn alt tipdir.
- Diskalkuliya: 3–7% (Şalev R.S., «Pediatr Neurol», 2007 icmalına görə).
- Disqrafiya: 4–7% (Berninger V.W. Top Lang Disord 2008).
- Cins: oxuma və yazma pozuntularında oğlanlarda 2–3 dəfə çox rast gəlir (qadınlarda diaqnozun az qoyulması hipotezi mövcuddur); riyaziyyat pozuntusunda cinslər bərabər.
- Komorbidlik: DDHP 30–40%, dil pozuntuları 50–60% (oxuma pozuntusunda), narahatlıq, depressiya, davranış pozuntuları riski artırır.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

- İrsilik: disleksiyada 50–70% (Pennington B.F. Cogn Neuropsychol 2002 əkiz tədqiqatları icmalı).
- Müəyyən edilmiş risk genləri: DYX1C1 (15q21), KIAA0319 (6p22), DCDC2 (6p22), ROBO1 (3p12) — sinir miqrasiyası və korteks formalaşması ilə əlaqəli; lakin tək gen yox, poligen risk arxitekturasına malikdir.
- Riyaziyyat pozuntusunda da yüksək irsilik (təxminən 70%), MYT1L və digər genlər ehtimal edilir (Mascheretti S. və b. Trends Genet 2018).

4.2 Neyrobioloji mexanizmlər

- Disleksiya — fonoloji çatışmazlıq: sol perisilvian sahələrdə (Vernike sahəsi, bucaq qirusu, yuxarı temporal qirus) qeyri-tipik aktivasiya modelləri (Shaywitz S.E., Shaywitz B.A. Biol Psychiatry 2008 fMRI icmalı). Fonem-

qrafem (səs-hərf) uyğunlaşmasında çatışmazlıq oxuma çətinliyinin nüvəsidir.

- Diskalkuliya — say hissi (approximate number system) və işlək yaddaş: intraparietal şırım və prefrontal qabıqda funksional pozulma müəyyən edilir (Buttervort B., Trends Cogn Sci, 2010).
- Disqrafiya: motor planlaşdırma və ortografik kodlama çatışmazlıq; sol fusiform və premotor sahələr.

4.3 Mühit amilləri (modifikator)

- Erkən təhsil keyfiyyəti və oxuma təlimi metodologiyası — fonoloji yanaşmanın olmaması poligen riski olan uşaqda daha böyük akademik fərq yaradır.
- Aşağı sosial-ekonomik status — etiologiya deyil, identifikasiya və müdaxiləyə əlçatanlıq amilidir.
- Xroniki orta qulaq iltihabı — erkən fonoloji inkişafa təsir edə bilər.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Oxuma pozuntusu (disleksiya, 6A03.0)

- Sözlərin oxunmasında dəqiqsizlik və yavaşlıq — sözləri yavaş və çətinliklə oxuyur, hərfləri əvəz edir və ya buraxır.
- Fonoloji şüur çatışmazlıq — qafiyə, hərf-səs əlaqəsi, sözləri səslərə ayırma çətinliyi.
- Yazma və imla — fonetik qaydalara uyğun olmayan yazılış xətaları.
- Oxu başa düşməsi — söz oxunuşundakı defisitə görə ikincili pozulmadır.
- Erkən əlamətlər (məktəbəqədər) — hərf adlarını öyrənmə gecikməsi, qafiyə oyunlarında çətinlik, ad oxuma çətinliyi.

5.2 Yazılı ifadə pozuntusu (disqrafiya, 6A03.1)

- Əl yazısı keyfiyyətsiz, oxunaqsız, ləng.
- Cümlə qurma, qrammatika, paraqraf quruculuğunda çətinlik.
- İmla və durğu işarələrində davamlı xətalar.
- Yazılı və şifahi ifadə bacarıqları arasında böyük fərq.

5.3 Riyaziyyat pozuntusu (diskalkuliya, 6A03.2)

- Say hissi çatışmazlıq — kəmiyyət müqayisəsi, miqdarın qiymətləndirilməsi.

- Riyazi faktları (məs. çoxrəqəmli vurma əməliyyatları) yadda saxlama çətinliyi.
- Riyazi əməliyyatlar — toplama, çıxma, çoxmərhələli problemlərdə yavaşlıq və xətalar.
- Mətnli məsələlərin həllində çətinlik.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11 konsensus nöqtələri)

A. Akademik bacarıqların əldə edilməsində və istifadəsində davamlı çətinliklər — ən az 6 aydır, yaşa uyğun məqsədli müdaxiləyə baxmayaraq davam edir. Aşağıdakı simptomlardan ən azı biri:

1. Sözləri oxumada qeyri-dəqiqlik və ya yavaşlıq;
2. Oxuduğu mətni başa düşməkdə çətinlik;
3. İmla çətinlikləri;
4. Yazılı ifadədə çətinliklər (qrammatika, durğu, təşkilat);
5. Say hissi və hesab bacarıqlarında çətinliklər;
6. Riyazi mühakimədə çətinliklər.

B. Akademik bacarıqlar yaşa uyğun gözlənilən səviyyədən əhəmiyyətli aşağıdır — standartlaşdırılmış testlərdə (xronoloji yaş üçün standart kənaraçıxmanın (SD) -1,5 dəyəri və ya aşağı) sənədləşdirilmiş, akademik və ya peşə fəaliyyətində funksional pozulma yaradır.

C. Çətinliklər məktəb yaşında başlayır (lakin akademik tələblər artana qədər tam görünməyə bilər).

D. İstisnalar — intellektual əlillik, eşitmə/görmə çatışmazlıq, başqa neyroloji və ya psixiatrik vəziyyət, psixososial məhrumiyyət, akademik təhsil dilində səlislik problemi, yetərsiz təhsillə tam izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: «IQ-akademik bacarıq diskrepansiya» modeli ləğv edilmişdir — diaqnoz üçün IQ hədd dəyəri tələb edilmir; uzun müddətli müdaxiləyə cavabsızlıq vacibdir. Şiddət: yüngül, orta, ağır — adaptiv funksiyaya görə.
- XBT-11 (6A03): paralel struktur; alt-spesifikasiyalar (oxuma, yazma, riyaziyyat). Şiddət həmçinin əlavə səciyyələndirici deyil.
- IDA — International Dyslexia Association: disleksiya — neyrobioloji mənşəli, fonoloji emaldakı çatışmazlıq; neyroinformasiya emalı pozuntusu.

Standartlaşdırılmış qiymətləndirmə və müdaxiləyə cavabın müşahidəsi (Response to Intervention, RTI) tövsiyə edilir.

- AAP Clinical Report on Dyslexia (Handler S.M., Fierson W.M. Pediatrics 2011, reaffirmed): diaqnoz pediatrlar tərəfindən istiqamətləndirilməli, qiymətləndirmə multidissiplinar — psixoloq + nitq-dil patoloqu + təhsil mütəxəssisi.
- NICE: həmçinin öyrənmə pozuntusu üzrə klinik göstəriş yoxdur; əsas çərçivə təhsil sistemi (ing. SEND Code of Practice, EHCP) daxilindədir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Müəllim və valideyn müsahibəsi — akademik tarixçə və müdaxiləyə cavab.
2. Görmə və eşitmə testləri (sensor pozuntular istisna olmaqla).
3. Standartlaşdırılmış akademik bacarıq testləri — Vudkok-Conon IV, WIAT-4 (fərdi nailiyyət testi), KTEA-3 (Kaufman təhsil nailiyyəti testi).
4. Fonoloji şüur və oxuma qiymətləndirməsi — CTOPP-2, GORT-5, TOWRE-2.
5. Riyaziyyat üçün — KeyMath-3, TEMA-3.
6. İntellektual qiymətləndirmə (WISC-V) — intellektual əlillik istisnası üçün; diskrepansiya artıq diaqnoz üçün lazım deyil.
7. Diqqət, icra funksiyası (BRIEF-2), işlək yaddaş qiymətləndirməsi.
8. Müdaxiləyə cavab (Response to Intervention, RTI) sənədləşdirilməsi — 6 aydan çox yaşa uyğun müdaxiləyə baxmayaraq davam edən çətinlik.
9. Komorbidliyin ilk aşkarlanması (skrininq) — DDHP, dil pozuntusu, narahatlıq, depressiya.

6.4 Differensial diaqnostika (cədvəl 2)

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
İntellektual inkişaf pozuntusu (6A00)	Akademik çatışmazlıq ümumi koqnitiv çatışmazlıq kontekstində; adaptiv funksiya da pozulmuşdur.
İnkişaf nitq və dil pozuntuları (6A01)	Şifahi dilin əldə edilməsi pozulub; oxuma və imla problemləri ikincilidir.

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
DDHP (6A05)	Diqqət defisiti akademik nailiyyəti azaldır; standartlaşdırılmış testlərdə akademik bacarıqlar diqqət pozuntusu nəzərə alındıqda adətən gözlənilən səviyyədə olur. Komorbidlik tez-tez rast gəlir.
Görmə/eşitmə pozuntusu	Sensor müayinə ilə aşkar olunur.
Sosial-ekonomik məhrumiyyət, yetərsiz təhsil	Uyğun təhsil mühitində akademik nailiyyət bərpa olur.
İkinci dilin öyrənilməsi (ing. English Language Learner)	Ana dilində akademik bacarıqlar yoxlanılmalıdır; ikidillilik özü-özlüyündə diaqnoz üçün əsas deyil.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Standartlaşdırılmış testlər

- Akademik bacarıqlar: Woodcock-Johnson IV (kompleks), WIAT-4 (ing. Wechsler Individual Achievement Test), KTEA-3.
- Oxuma: GORT-5 (ing. Gray Oral Reading Test), TOWRE-2 (ing. Test of Word Reading Efficiency), CTOPP-2 (ing. Comprehensive Test of Phonological Processing).
- Riyaziyyat: KeyMath-3, TEMA-3 (ing. Test of Early Mathematics Ability).
- İntellekt və idrak funksiyaları: WISC-V (Wechsler uşaq intellekti şkalası).
- İcra funksiyası: BRIEF-2 (valideyn/müəllim sorğusu).
- İşlək yaddaş, emal sürəti: WISC-V indeksləri, rəqəm diapazonu testi, «Trail Making» (izləmə) testi

7.2 Laborator müayinələr

Rutin laborator müayinə üçün göstəriş yoxdur. Spesifik klinik şübhə əsasında:

- Qurğuşun səviyyəsi — risk amilləri varsa.
- Tiroid funksiyası — anadangəlmə hipotireoz aşkar edilməmişsə.
- Genetik müayinə — komorbid intellektual əlillik olduqda. və ya sindromal əlamətlər varsa.

7.3 İnstrumental müayinələr

- Beyin maqnit-rezonans tomoqrafiyası (MRT) — rutin göstəriş yoxdur; fokal nevroloji əlamətlər, tutmalar, reqressiya olduqda.
- Elektroensefaloqrafiya (EEQ) — tutma şübhəsi, Landau-Kleffner sindromu istisna edildikdə.
- Eşitmə testi və görmə testi — bütün hallarda mütləq ilkin müayinə metodlarıdır.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (IDA, AAP 2011, APA, NASP konsensus)

1. İnkişaf öyrənmə pozuntusu farmakoloji yolla müalicə edilmir. Müdaxilə — sübuta əsaslanan təhsil və terapiyadır.
2. Erkən identifikasiya və müdaxilə — məktəbəqədər və erkən məktəb yaşlarında müdaxilənin effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. RTI (ing. Response to Intervention) modeli — yaşa uyğun müdaxilə pillə-pillə, cavabsızlıq diaqnostik qiymətləndirməyə əsas verir.
3. Disleksiya — Strukturlaşdırılmış savadlılıq (ing. Structured Literacy) yanaşması: sistematik, ardıcıl, eksplisit, multisensor, diaqnostik təlim. Fonoloji şüur + fonem-qrafem uyğunlaşması + söz strukturu + sintaksis + semantika. Orton-Qillinghem, Wilson Reading System və Lindamood-Bell tipik proqramlardır.
4. Diskalkuliya: Konkret-Təsviri-Abstrakt (KTA/CRA) təlimi; say hissi inkişafı, riyazi faktların yadda saxlanması məşqləri.
5. Disqrafiya: əl yazısı təlimi (ing. məsələn, Handwriting Without Tears), klaviatura öyrənmə, söz və cümlə quruculuğu strategiyaları, səsi mətnə çevirən texnologiya.
6. Akademik akkomodasiya: əlavə vaxt, səsli kitablar, klaviatura, mətnoxuyucu proqramlar (text-to-speech), kalkulyator riyaziyyatda — IEP / EHCP daxilində.
7. Komorbidlik müalicəsi: DDHP — stimulyantlar; narahatlıq və depressiya — kognitiv-davranış terapiyası (KDT); dil pozuntusu — nitq-dil patoloqu (SLP).
8. Sosial-emosional dəstək: öyrənmə pozuntusu olan uşaqlarda özünə hörmət, motivasiya, narahatlıq problemləri yüksək risk qrupundadır.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Orton-Gillingham (OG) yanaşması — Strukturlaşdırılmış multisensor fonema-qrafema əsaslı oxuma və imla təlimi. Disleksiya üçün birinci sıra

metodologiyadır; sertifikatlaşdırılmış müəllim/terapevt tərəfindən aparılır. Sübut: Stevens E.A. və b. J Learn Disabil 2021 meta-analiz — orta effekt ölçüsü oxuma və imlada. Orton-Qillinghem Təcrübəçiləri Akademiyası.

2. Uilson Oxu Sistemi (ing. Wilson Reading System) — Orton-Gillingham prinsiplərinə əsaslanan, 12 pilləli kompleks oxuma və imla proqramı; 6 yaşdan yetkinliyə qədər. wilsonlanguage.com.
3. Lindamood-Bell proqramları — LiPS (ing. Lindamood Phoneme Sequencing) — fonoloji şüuru motor-kinestetik komponentlə birləşdirir; «Seeing Stars» (ulduzları görmə) proqramı orfoqrafik kodlamaya yönəlir. lindamoodbell.com.
4. Strukturlaşdırılmış Savadlılıq (ing. Structured Literacy — IDA Knowledge and Practice Standards) — Spesifik proqram deyil, çərçivədir — sistematik, ardıcıl, eksplisit, multisensor, diaqnostik təlim prinsipləri. Orton-Gillingham, Wilson, Lindamood-Bell və başqaları bu çərçivəyə uyğundur. dyslexiaida.org.
5. Konkret-Təsviri-Abstrakt Təlim (ing. KTA / CRA — Concrete-Representational-Abstract Instruction) — Diskalkuliya üçün — konkret manipulyativ vasitələrlə başlayan, sonra təsviri (şəkilli) mərhələyə, daha sonra mücərrəd simvolik əməliyyatlara keçidlə təlim. Sübut: Witzel B.S. və b. J Spec Educ Technol 2003.
6. «Gözyaşsız əl yazısı» (ing. Handwriting Without Tears) proqramı — Olsen C. — Disqrafiya və yazma çətinliklərində istifadə olunan multisensor əl yazısı təlimi proqramı. lwtears.com.
7. Müdaxiləyə Cavab (RTI — Response to Intervention) / Çoxpilləli Dəstək Sistemi (ing. Multi-Tiered System of Supports, MTSS) — 3 pilləli çərçivə — 1-ci pillə: universal səviyyəli keyfiyyətli təlim; 2-ci pillə: hədəfli kiçik qrup müdaxiləsi; 3-cü pillə: intensiv fərdi müdaxilə. ABŞ-da «Əlilliyi olan şəxslərin təhsili haqqında» qanun (IDEA, 2004) ilə təsbit edilmişdir; oxşar çərçivələr digər ölkələrdə.
8. Köməkçi Texnologiya (ing. Assistive Technology) — mətnin səsləndirilməsi (Read&Write, NaturalReader), səsin mətnə çevrilməsi (ing. Dragon NaturallySpeaking), audio kitablar (ing. Bookshare, Learning Ally), riyaziyyat üçün hesablama vasitələri — funksional kompensasiya. AAP və IDA tərəfindən tövsiyə edilir.
9. Bu testlər 7.1 «Standartlaşdırılmış testlər» bölməsinə köçürülməlidir. — Fonoloji şüurun standartlaşdırılmış qiymətləndirilməsi — disleksiyanın aşkarlanmasında əsas metod hesab edilir.
10. GORT-5 (ing. Gray Oral Reading Test) və TOWRE-2 — Oxuma sürətinin, dəqiqliyinin və axıcılığının ölçülməsi.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- IDA-nın «Oxu təlimçiləri üçün bilik və təcrübə standartları» (2018): strukturlaşdırılmış savadlılıq çərçivəsi.; sertifikatlaşdırılmış müəllim tələbi.
- AAP 2011 (Handler və Fierson): disleksiya bioloji əsaslı; akademik müdaxilə birinci sıra müalicədir; vizual terapiya əksgöstərişdir (bax: 10.3).
- National Reading Panel (NRP) 2000: beş əsas oxuma komponenti — fonoloji şüur, fonetik metod (fonika), axıcılıq, lüğət, başa düşmə.
- NASP (ing. National Association of School Psychologists): RTI çərçivəsində 3 pillə — universal skrininq, hədəfli müdaxilə, intensiv fərdi müdaxilə.

9. Proqnoz

9.1 Yaxşı proqnoz amilləri

- Erkən aşkarlanma (məktəbəqədər və ya erkən məktəb yaşında).
- Sübuta əsaslanan strukturlaşdırılmış savadlılıq müdaxiləsi.
- Yüksək IQ — kompensator strategiyaların inkişafı.
- Davamlı ailə dəstəyi və motivasiya.
- Yalnız bir akademik sahə təsir (məs. tək oxuma, riyaziyyat normal).

Pis proqnoz amilləri

- Gec identifikasiya (məktəb yaşının ortası və ya sonu).
- Çoxsaylı akademik domenlərə təsir.
- Komorbid DDHP, dil pozuntusu, narahatlıq.
- Aşağı sosial-ekonomik dəstək, məhdud təhsil resursları.
- Müdaxilə sübutsuz metodlarla (rəngli linzalar, vizual terapiya, «Brain Gym» — beyin gimnastikası).

İzləmə hədəfləri

- Akademik nailiyyətin izlənməsi — illik standartlaşdırılmış testlər.
- Sosial-emosional sağlamlıq — özünə hörmət, narahatlıq, depressiya skrininq.
- Komorbid DDHP və dil pozuntusu üçün həmçinin ayrı müdaxilə.
- Yetkinlikdə peşə və akademik akkomodasiya planlaşdırması (ali təhsildə əlilliyə dair imkanlar, iş yerində uyğunlaşma).

- Köməkçi texnologiya istifadəsinin gücləndirilməsi (mətnin səsləndirilməsi, kalkulyator).

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «Disleksiya — uşağın tənbəlliyi və ya pis tərbiyəsinin nəticəsidir»

Niyə yayılmışdır: «kifayət qədər çalışsa, oxuya bilər» inancı; akademik çətinliyin xarakter qüsuru kimi yanlış izahı.

Klinik və bioloji məntiq: Disleksiya — neyrobioloji pozuntudur. fMRI tədqiqatları (Shaywitz S.E. Biol Psychiatry 2008) sol perisilvian sahələrdə qeyri-tipik aktivasiya nümunələrini göstərmişdir; irsilik 50–70%, identifikasiya olunmuş risk genləri (DYX1C1, KIAA0319, DCDC2). Pasiyent eyni nəticəyə çatmaq üçün daha çox koqnitiv səy sərf etməyə məcburdur — bu isə xroniki tükənməyə gətirir.

Sübut: IDA Definition (2002, yenilənmə) — «Disleksiya neyrobioloji mənşəli inkişaf öyrənmə pozuntusudur.»

Praktik klinik addım: ailəyə bioloji əsaslar izah edilməlidir; günahlandırma əvəzinə sübutlu Strukturlaşdırılmış savadlılıq (ing. Structured Literacy) müdaxiləsi və akademik akkomodasiya.

Mif 2: «Disleksiya — uşaqların hərfləri tərs (mirror) yazmasıdır»

Niyə yayılıb: Orton 1925 «strephosymbolia» termini və populyar mediada təkrarlanan obraz.

Klinik və bioloji məntiq: Hərf əksinə yazma və oxuma 4–7 yaş arasında bütün uşaqlarda normaldır; 8 yaşdan sonra davam edən hərf inversiyası klinik şübhə yarada bilər, lakin disleksiyanın əsas əlaməti deyil. Disleksiyanın nüvəsini fonoloji emalındakı defisit təşkil edir.

Sübut: Stanovich K.E. (2000) — fonoloji çatışmazlıq nəzəriyyəsi; vizual-spatial çatışmazlıq ilkin etiologiya deyil.

Mif 3: «Disleksiyalı uşaqlar yaşa görə „keçəcəklər“, müdaxiləyə ehtiyac yoxdur»

Sübut: Bruck M. Dev Psychol 1992 — uzunmüddətli izləmə tədqiqatları: müdaxilə almayan disleksiyalı uşaqlar yetkinlikdə də oxuma çətinliklərini saxlayırlar; akademik və peşə nəticələri əlverişsizdir. Müdaxilə nə qədər tez başlasa, kompensasiya potensialı bir o qədər yüksəkdir.

10.2 Zərərli və ya elmi cəhətdən əsassız üsullar

Mif 4: «Rəngli linzalar (Irlen lensləri) və ya rəngli üst-örtüklər disleksiyanı sağaldır»

Niyə yayılıb: 1980-ci illərdə Helen Irlen tərəfindən «skotopik həssaslıq sindromu» konsepsiyası; kommersiya optometrik klinikalarının reklam fəaliyyəti.

Sübut: AAP, AAO (ing. American Academy of Ophthalmology) və AAPOS (ing. American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus) 2009 və 2014 Ortaq Bəyanatları: rəngli linzaların və üst-örtüklərin disleksiya üçün effekti sübut edilməmişdir; Cochrane (Evans B.J., Allen P.M. 2016) sistematik icmal — kifayət qədər effekt sübutu yoxdur. Bu üsullar birinci sıra müdaxiləni (strukturlaşdırılmış savadlılığı) təxirə salır.

Real klinik addım: ailəyə açıq izah; müdaxilə kimi sübutlu fonoloji oxuma proqramı.

Mif 5: «Vizual terapiya (göz məşqləri) disleksiyanı sağaldır»

Sübut: AAP, AAO, AAPOS 2009 Ortaq Bəyanatı — disleksiyanın göz hərəkəti pozuntusu deyil, dilə əsaslanan pozuntu olduğunu vurğulayır; göz məşqlərinin oxuma nəticələrinə təsiri sübut edilməmişdir. Vizual terapiya yalnız konkret göz hərəkəti pozuntularında (məs. konvergens çatışmazlığı) göstərişdir.

Mif 6: «Beyin gimnastikası» (ing. Brain Gym) / təhsil kineziologiyası

Sübut: Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007 sistemli icmal — iddiaları neyrobiologiyaya uyğunlaşmır; akademik nailiyyətə təsiri yoxdur. Konversiya proqramı kimi tənqid olunur.

Mif 7: «Dore proqramı» (ing. Cerebellar Exercise Therapy — serebellar məşq terapiyası)

Niyə yayılıb: Wynford Dore 2000-ci illərdə serebellar (beyincik) funksiyasını oxuma ilə əlaqələndirən nəzəriyyəni populyarlaşdırdı; «müsbət nəticələr» bəyanatları KİV-in diqqətini cəlb etdi.

Sübut: Reynolds və Nikolsonun ilkin tədqiqatları metodoloji cəhətdən ciddi tənqid almışdır (Bishop D.V. Dyslexia 2007); təkrar tədqiqatlarda təsir təsdiqlənməmişdir. British Dyslexia Association — Dore proqramı tövsiyə etmir.

10.3 Səmərəsiz və ya əsas müdaxiləni təxirə salan üsullar

Mif 8: «Whole Language» yanaşması fonika əvəzinə oxumanı öyrədir

Sübut: National Reading Panel 2000 (NRP) — sistematik fonetik təlim aşkar üstündür «bütöv dil» (ing. whole language) yanaşmasından, xüsusilə öyrənmə çətinliyi olan uşaqlarda. Eyni mövqe Endrew F. v. Douglas County (US Supreme Court 2017) qərarı ilə təhsil hüquqi standartlarına daxil edilmişdir. «Oxuma müharibələri» (ing. Reading Wars) mübahisəsi əsasən sistematik fonetikanın lehinə həll olunmuşdur.

Mif 9: «Eşitmə inteqrasiyası təlimi / Tomatis üsulu (ing. Tomatis method) disleksiyanı sağaldır»

Sübut: ASHA Position Statement 2004 — AIT-in disleksiya və ya öyrənmə pozuntusu üçün effekti sübut edilməyib.

Mif 10: «EEG Neyrofidbek disleksiyanı və ya diskalkuliyanı sağaldır»

Sübut: inkişaf xarakterli öyrənmə pozuntusu (XBT-11: 6A03) üçün neyrofidbek effekti sübut edilməmişdir. DDHP-də cüzi təsir (Holtmann 2011), lakin öyrənmə pozuntularına ekstrapolyasiya əsassızdır.

Mif 11: «Xüsusi pəhriz (qlütensiz, omeqa-3 yüksək doza, „beyin qidası“) disleksiyanı sağaldır»

Sübut: Cochrane və sistemli icmallar (Tan M.L. və b. J Pediatr 2012 omega-3 üçün) — disleksiyada davamlı klinik effekt sübut edilməyib. Bəzi tədqiqatlarda kiçik təsir göstərilmişdir, lakin metodoloji məhdudiyyətlər mövcuddur.

Mif 12: «Hiperbarik oksigen kamerası Hiperbarik oksigen terapiyası (ing. HBOT) və ya kök hüceyrə yeridilməsi»

Sübut: inkişaf xarakterli öyrənmə pozuntusu üçün təsir sübutu yoxdur; risk profili əhəmiyyətlidir (HBOT — pnevmotoraks; kök hüceyrə — infeksiya, ölüm halları).

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və Xəstələnmə Statistikası üzrə Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A03 İnkişaf xarakterli öyrənmə pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. Vaşinqton: APA Publishing; 2022.
3. Beynəlxalq Disleksiya Assosiasiyası (IDA). Disleksiyanın tərifi. 2002, yenilənmiş. dyslexiaida.org

4. Beynəlxalq Disleksiya Assosiasiyasının (IDA) Oxu Müəllimləri üçün Bilik və Təcrübə Standartları. 2018.
5. Handler S.M., Fierson V.M.; Amerika Pediatriya Akademiyasının (AAP) Oftalmologiya Bölməsi və Əlilliyi olan Uşaqlar üzrə Şurası. Birgə Texniki Hesabat — Öyrənmə əlilliklər, disleksiya və görmə. «Pediatriya» (Pediatrics). 2011;127(3):e818–e856.
6. Milli Oxu Paneli. Uşaqlara oxumağı öyrətmək: oxu üzrə elmi tədqiqat ədəbiyyatının sübuta əsaslanan qiymətləndirilməsi və onun oxu təliminə təsirləri. ABŞ Milli Səhiyyə İnstitutları (NIH); 2000.
7. Pennington B.F. İnkişaf pozuntularının tək defisit modelindən çoxsaylı defisit modellərinə. «Koqnitiv Neyropsixologiya» (Cogn Neuropsychol). 2002;19(5):385–414.
8. Şayvits S.E., Şayvits B.A. Oxumağa diqqət yetirmək: oxu və disleksiyanın neyrobiologiyası. «Bioloji Psixiatriya» (Biol Psychiatry). 2008;63(3):219–225.
9. Buttervort B. Əsas say qabiliyyətləri və diskalkuliyanın mənşəyi. «Koqnitiv Elmlər Tendensiyaları» (Trends Cogn Sci). 2010;14(12):534–541.
10. Şalev R.S. İnkişaf xarakterli diskalkuliyanın yayılması. «Pediatrik Nevrologiya» (Pediatr Neurol). 2007;37(6):385–391.
11. Berninger V.V., Niedo C. Böyüklərdə afaziya və nitq apraksiyasının uşaqlarda disleksiya və disqrafiya ilə müqayisəsi. «Dil Pozuntuları üzrə Mövzular» (Top Lang Disord). 2008;28(2):143–153.
12. Stevens E.A., Ostin K., Mur K. və b. Sübutların mövcud vəziyyəti: söz səviyyəsində oxu əlilliyi olan və ya risk altında olan şagirdlər üçün Orton-Gillingham oxu müdaxilələrinin təsirlərinin araşdırılması. «Öyrənmə Əlilliklər Jurnalı» (J Learn Disabil). 2021;54(6):399–414.
13. Bruk M. Disleksik şəxslərdə fonoloji şüur defisitlərinin davamlılığı. «İnkişaf Psixologiyası» (Dev Psychol). 1992;28(5):874–886.
14. Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP), Amerika Oftalmologiya Akademiyası (AAO), Amerika Uşaq Oftalmologiyası və Strabismus Assosiasiyası (AAPOS). Birgə Bəyanat — Öyrənmə əlilliklər, disleksiya və görmə. «Pediatriya» (Pediatrics). 2009;124(2):837–844.
15. Evans B.C., Allen P.M. İntuitiv Örtüklərdən (ing. Intuitive Overlays) və ya İntuitiv Kolorimetrdən (ing. Intuitive Colorimeter) istifadə etməklə vizual stress üzrə nəzarətli sınaqların sistematik icmalı. «Optometriya Jurnalı» (J Optom). 2016;9(4):205–218.
16. Vitsel B.S., Merser K.D., Miller M.D. Öyrənmə çətinliyi olan şagirdlərə cəbrin öyrədilməsi: açıq təlimat modelinin tədqiqi. «Xüsusi Təhsil Texnologiyaları Jurnalı» (J Spec Educ Technol). 2003;18(3):27–34.

17. Hayatt K.C. Beyin Gimnastikası (ing. Brain Gym): daha güclü beyinlər qurmaq, yoxsa boş arzu? «Korreksiya və Xüsusi Təhsil» (Remedial Spec Educ). 2007;28(2):117–124.
18. Bişop D.V.M. Motor koordinasiyanın məşqi ilə disleksiya və diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun müalicəsi: möcüzə, yoxsa mif? «Disleksiya» (Dyslexia). 2007;13(1):4–7.
19. Tan M.L., Ho C.C., Teh K.H. Spesifik öyrənmə pozuntuları olan uşaqlar üçün çoxdoymamış yağ turşuları (PUFAs). «Koçreyn Sistematik İcmallar Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2012;(12):CD009398.
20. Olsen C.Z. Gözyaşsız əl yazısı (ing. Handwriting Without Tears). Kabin Con: Handwriting Without Tears; 2008.
21. Reynolds D., Nikolson R.I., Hambli H. Oxu çətinliyi olan uşaqlar üçün məşqə əsaslanan müalicənin qiymətləndirilməsi. «Disleksiya» (Dyslexia). 2003;9(1):48–71.
22. Snoulinq M.C., Hulm K. Reynolds, Nikolson və Hamblinin (2003) DDAT-ın oxu çətinliyi olan uşaqlar üçün effektiv müalicə olması barədə iddialarına tənqidi yanaşma. «Disleksiya» (Dyslexia). 2003;9(2):127–133.

XBT-11 **6A04**	**6A04 İNKİŞAF HƏRƏKİ KOORDİNASİYA POZUNTUSU (İHKP)** **Developmental motor coordination disorder**
XBT-10 F82	Motor funksiyaların inkişafının spesifik pozuntuları
DSM-5-TR F82	İnkişaf koordinasiya pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

İnkişaf hərəki koordinasiya pozuntusu (XBT-11: 6A04; DSM-5-TR: 315.4/F82) İnkişaf xarakterli hərəki koordinasiya pozuntusu (İHKP; ing. developmental coordination disorder) — uşağın xronoloji yaşı, intellektual səviyyəsi və motor bacarıqları öyrənmə imkanları nəzərə alındıqda gözlənilməyən, gündəlik motor bacarıqların əldə edilməsində və icrasında davamlı çətinliklərlə təzahür edən neyroinkişaf pozuntusudur.

Köhnə adlandırmalar — «clumsy child syndrome», «developmental dyspraxia», «minimal beyin disfunksiyası» — müasir klinik təcrübədə tərk edilmiş, İHKP termini ilə əvəz olunmuşdur (Polatajko H.J., Fox A.M., Missiuna C. Can J Occup Ther 1995, «Leeds Consensus 2006»).

2. Tarixçə

- 1937 — Orton S.T. «developmental clumsiness» konsepsiyası.
- 1960–70-ci illər — «minimal beyin disfunksiyası» (MBD) — geniş yayılmış və qeyri-dəqiq termin, sonradan tərk edilmişdir.
- DSM-III-R (1987) — DSM-III-R (1987)-də «inkişaf xarakterli koordinasiya pozuntusu» rəsmi diaqnostik kateqoriya kimi müəyyən edilmişdir.
- Lids konsensusu (2006) — beynəlxalq mütəxəssis qrupu «İHKP» terminini standartlaşdırmışdır; «dispraksiya» və «İHKP» sinonim kimi qəbul edilməməsi haqqında bəyanat (dispraksiya — daha dar konsepsiya, motor planlaşdırma çatışmazlıq).
- EACD (ing. European Academy of Childhood Disability) International Clinical Practice Recommendations (Beynəlxalq klinik təcrübə tövsiyələri) — 2012, 2019 yeniləməsi (Blank R., Barnett A.L., Cairney J. və b. Dev Med Child Neurol 2019) — diaqnostika, müayinə və müdaxilə üzrə beynəlxalq standart.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — İHKP ümumi neyroinkişaf pozuntuları kateqoriyasına daxil edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: məktəb yaşlı uşaqlarda 5–6% (EACD 2019; Lingam R. və b. Pediatrics 2009 İngiltərə ALSPAC tədqiqatı n > 6900).
- Cins: oğlanlarda 2–7 dəfə yüksəkdir (qızlarda diaqnozun az qoyulması hipotezi mövcuddur).
- Davamlılıq: pasiyentlərin 50–70%-də motor çətinliklər yetkinlikdə də davam edir (Cantell M.H. və b. J Adolesc Res 2003 izləmə; Kirby A. və b. Res Dev Disabil 2010).
- Komorbidlik: DDHP 50%, spesifik öyrənmə pozuntusu 50%, autizm spektri pozuntusu (6A02) 5–10%, inkişaf xarakterli dil pozuntusu 20–30%, narahatlıq və depressiya üzrə yeniyetməlikdə risk artmışdır.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik və neyrobioloji amillər

- İrsilik tədqiqatları məhduddur, lakin ailədə İHKP tarixçəsi risk amili kimi göstərilir (Gaines R. və b. Phys Occup Ther Pediatr 2008).
- Neyrobioloji — beyincik (serebellum), bazal qanqlionlar, parietal qabıq və premotor sahələrin funksional əlaqəsində qeyri-tipik modellər (Zwicker J.G. və b. Eur J Paediatr Neurol 2012 fMRI icmalı). Daxili modelləşdirmə (ing. internal modeling) çatışmazlıq hipotezi — motor planlaşdırmadan əvvəl proqnozlaşdırma və müqayisə proseslərinin pozulması (Adams I.L. və b. Dev Med Child Neurol 2014).

4.2 Risk amilləri

- Erkən doğum (<32 həftə) və aşağı doğum çəkisi (<1500 q) — İHKP riskini 6–8 dəfə artırır (Edwards J. və b. Dev Med Child Neurol 2011 sistemli icmal).
- Hamiləlik dövründə ananın alkoqol istifadəsi fetal alkoqol spektri pozuntuları (FASD) çərçivəsində motor çətinliklər müşahidə olunur.
- Perinatal hipoksik-işemik hadisələr risk amili kimi qiymətləndirilir.
- Ailə tarixçəsində İHKP və ya digər neyroinkişaf pozuntuları.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Motor bacarıqları sahələrinə görə

- İri (kobud) motorika (ing. gross motor): qaçma, atlama, top oyunları, velosiped sürmə, balansda çətinlik; idman fəaliyyətindən qaçınma.
- İncə motorika (ing. fine motor): əl yazısının keyfiyyəti aşağı, tempi ləngdir, qayçı, ipləri bağlama, düymələmə, çəngəl-bıçaq istifadəsi.
- Motor planlaşdırma və icrası: yeni motor bacarıqların öyrənilməsində ləngləmə; ardıcıllıq və ritm problemi.
- Vizual-motor inteqrasiya: kopyalama, rəsm, hərflərin formalaşdırılmasında çətinlik.

5.2 Gündəlik funksional pozulma

- Özünə qulluq — geyim, qida qəbulu, higiyena.
- Akademik fəaliyyət — əl yazısı tempi, vərəq təşkilatı, idmanla məşğul olma.
- İcma fəaliyyəti — oyun meydançası, idman komandaları, maraq dairələri.

- Psixososial nəticələr — özünə hörmətin azalması, narahatlıq, depressiv əhval, sosial təcrid (Cairney J. və b. Dev Med Child Neurol 2013).

5.3 Trayektoriya

Erkən əlamətlər (1–3 yaş) — motor mərhələlərin gecikməsi (oturma, ayaq üstə durma, ilk addımlar normal vaxtda və ya gec; müəyyən hərəkətlərin keyfiyyəti zəifdir). Məktəbəqədər və erkən məktəb yaşında çətinliklər aydın görünür; akademik tələblərin artması ilə (yazma, vərəq işi) pozulma daha qabarıq olur. Yetkinlikdə sürücülük, peşə tələbləri və idman fəaliyyətində davamlı çətinliklər qalır (50–70%).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11, EACD 2019 konsensus nöqtələri)

A. Motor bacarıqların əldə edilməsi və icrası — xronoloji yaş və motor öyrənmə imkanları nəzərə alındıqda gözlənilən səviyyədən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Çətinliklər ləngləməyə, qeyri-dəqiqliyə, motor bacarıqların yerinə yetirilməsində qeyri-koordinasiyaya səbəb olur.

B. Motor bacarıq çatışmazlıq xronoloji yaşa uyğun gündəlik həyat fəaliyyətinə əhəmiyyətli və davamlı şəkildə mane olur (məs. özünə qulluq, akademik nailiyyət, peşə fəaliyyəti, oyun və idman).

C. Başlanğıc erkən inkişaf dövrünə təsadüf edir.

D. İstisnalar — intellektual əlillik, görmə pozuntusu və ya başqa neyroloji vəziyyət (məs. serebral iflic, əzələ distrofiyası, degenerativ pozuntular) ilə tam izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- EACD 2019 (Blank və b.): dörd diaqnostik meyar standartlaşdırılmışdır — motor bacarıq testində 5–15-ci persentildən aşağı nəticə (ing. Movement Assessment Battery for Children, MABC-2 və ya bənzər); gündəlik fəaliyyət pozulması; başlanğıc erkən inkişaf dövründə; başqa tibbi vəziyyətlə izah olunmama. multidissiplinar qiymətləndirmə (pediatr və ergoterapevt və ya fizioterapevt) tövsiyə edilir. Diaqnozun 5 yaşdan qoyulması tövsiyə edilir (motor bacarıqlar stabilləşdikdən sonra); 5 yaşa qədər «Müvəqqəti İHKP» və ya «motor inkişaf gecikməsi» termini istifadə oluna bilər.
- DSM-5-TR: EACD ilə paralel meyarlar; «dispraksiya» termini istifadə edilmir.

- XBT-11: inkişaf xarakterli hərəki koordinasiya pozuntusu (6A04); alt-spesifikasiyalar yoxdur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Valideyn və müəllim müsahibəsi — inkişaf tarixçəsi, motor mərhələləri, gündəlik fəaliyyət problemləri.
2. Standartlaşdırılmış motor testi — MABC-2 (ing. Movement Assessment Battery for Children-2, 3–16 yaş) və ya BOT-2 (ing. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2, 4–21 yaş)
3. Funksional gündəlik fəaliyyətin qiymətləndirilməsi — DCDQ (Developmental Coordination Disorder Questionnaire, valideyn forması), VABS adaptiv komponenti.
4. Görmə testi — sensor pozuntu istisnası.
5. Neyroloji müayinə — serebral iflic, ataksiya və neyromüskül xəstəliklərinin istisnası üçün.
6. Komorbidlik skrininq — DDHP (Conners), spesifik öyrənmə pozuntusu, autizm spektri pozuntusu, inkişaf xarakterli dil pozuntusu.
7. İntellektual qiymətləndirmə — yalnız ümumi inkişaf gecikməsi və ya intellektual əlillik şübhəsi varsa.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Serebral parez	Spastiklik, hiperrefleksiya, sabit neyroloji əlamətlər; MRT tipik tapıntılar.
Əzələ distrofiyası (Düşen, Bekker)	Proqressiv əzələ zəifliyi; kreatin kinaza (CK) səviyyəsi yüksək; ailə tarixçəsi.
Anadangəlmə miopatiya, neyropatiya	Spesifik neyroloji və EMG tapıntıları.
İntellektual əlillik (6A00)	Motor çatışmazlıq ümumi koqnitiv çatışmazlıq kontekstində.
Autizm spektri pozuntusu (6A02)	Motor stereotipiyaları, sosial-kommunikativ çatışmazlıq əsasdır.
DDHP (6A05)	DDHP-də diqqət çatışmazlığı motor icraya təsir edir; komorbidlik sıxdır (təxminən 50%).

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Görmə pozuntusu	Görmə testi pozulmuş.
Disqrafiya (6A03.1)	İncə motorika problemləri yazma kontekstində üstünlük təşkil edir; ümumi motor bacarıqlar normaldır.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Standartlaşdırılmış motor testlər

- MABC-2 (ing. Movement Assessment Battery for Children-2, 3–16 yaş) — qızıl standart; əl bacarığı, top bacarıqları, balans alt testləri.
- BOT-2 (ing. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2, 4–21 yaş) — geniş motor profili.
- DCDQ (Developmental Coordination Disorder Questionnaire, 5–15 yaş, valideyn forması) — funksional skrininq.
- PDMS-2 (Peabody Developmental Motor Scales, <6 yaş).
- BHK (ing. Concise Assessment Method for Children's Handwriting) — əl yazısı keyfiyyəti.

7.2 Laboratoriya müayinələri

Rutin göstəriş yoxdur. Spesifik klinik şübhə əsasında:

- CK (kreatin kinaza) — əzələ distrofiyası şübhəsi.
- tiroid funksiyası — bəzi hipotiroid hallarda motor ləngləmə.
- Genetik müayinə — sindroma xas əlamətlər olduqda.

7.3 İnstrumental müayinələr

- Beyin MRT (maqnit-rezonans tomoqrafiyası) — yalnız fokus neyroloji əlamətlər, ataksiya, sabit çatışmazlıq olduqda (serebellar/serebral patologiya istisnası).
- EMQ (elektromioqrafiya) / sinir keçiriciliyinin tədqiqi — neyromüskül xəstəlik şübhəsi.
- Görmə testi — bütün hallarda ilkin müayinə kimi tövsiyə edilir.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (EACD 2019 konsensusu)

1. İHKP farmakoloji yolla müalicə edilmir. Müdaxilə ergoterapiya/fizioterapiya əsaslıdır.
2. Erkən aşkarlanma və müdaxilə — funksional nəticələri yaxşılaşdırır.
3. Yuxarıdan-aşağıya (tapşırıq-yönəlmiş) yanaşma (ing. top-down) birinci xətt kimi — aşağıdan-yuxarıya sensorimotor yanaşmalardan üstün təsir göstərir (Smits-Engelsman B.C. və b. Dev Med Child Neurol 2013 meta-analiz).
4. Gündəlik Fəaliyyətə Koqnitiv Yönləndirmə (CO-OP) və Neyromotor Tapşırıq Təlimi (NTT) — EACD 2019-da birinci sıra tövsiyə edilən sübutlu yanaşmalar.
5. Funksional məqsədlər — pasiyentin və ailənin seçdiyi gündəlik fəaliyyət hədəfləri (məsələn, velosiped sürmə, geyim, əl yazısı).
6. Ailə və məktəb iştirakı — müdaxilə evdə və məktəbdə müşayiət olunmalıdır.
7. İntensivlik: həftədə 1–2 seans, 8–10 həftə adətən başlanğıc kurs; təsirin qiymətləndirilməsi əsasında uzadılır.
8. Komorbidlik müalicəsi — DDHP (stimulyantlar), öyrənmə pozuntusu (strukturlaşdırılmış oxu-yazı təlimi; ing. Structured Literacy), narahatlıq və depressiya (koqnitiv-davranış terapiyası — KDT).
9. Akademik akkomodasiya — əl yazısı tempinin azaldılması, klaviatura istifadəsi, səs-mətn çevirmə (ing. voice-to-text), əlavə vaxt; idman dərslərində fərdiləşdirilmiş yanaşma.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Gündəlik Fəaliyyətə Koqnitiv Yönləndirmə (ing. CO-OP — Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) — Polatayko (Polatajko H.), Mandiç (Mandich A.) — Top-down koqnitiv-əsaslı yanaşma — uşaq motor probleminin həllində fəal iştirakçı olur. «Hədəf–Plan–İcra–Yoxlama» (ing. Goal-Plan-Do-Check) strategiyası ilə pasiyent öz hədəfini seçir, planlaşdırır, icra edir və qiymətləndirir. 10–14 seans, fərdi. Sübut: Smits-Engelsman B.C. və b. Dev Med Child Neurol 2013 meta-analiz — yuxarıdan-aşağıya yanaşmalar aşağıdan-yuxarıya yanaşmalardan üstündür; Thornton A. və b. Phys Occup Ther Pediatr 2016 sistemli icmal. EACD 2019 — birinci sıra tövsiyə.
2. Neyromotor Tapşırıq Təlimi (ing. Neuromotor Task Training, NTT) — Şumeyker M.M., Smits-Engelsman B.C. — Tapşırıq-yönəlmiş motor öyrənmə yanaşması — spesifik motor bacarıqların təkrarlanan,

strukturlaşdırılmış məşqi; vizual-motor inteqrasiya, balans, top bacarıqları. Sübut: Niemeijer A.S. və b. Phys Ther 2007. EACD 2019 — sübutlu.

3. MABC-2 (ing. Movement Assessment Battery for Children-2) — qızıl standart motor qiymətləndirmə; 3–16 yaş. Əl bacarığı (3 tapşırıq), top bacarıqları (2 tapşırıq), balans (3 tapşırıq) — yaşa uyğun norma cədvəlləri.
4. DCDQ (ing. Developmental Coordination Disorder Questionnaire) — 15 sual, valideyn doldurulan funksional skrininq vasitəsi (Wilson B.N. və b. Phys Occup Ther Pediatr 2009 yenilənmə).
5. BOT-2 (ing. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2) — 4–21 yaş, geniş motor profil; klinik və tədqiqat kontekstində istifadə.
6. «Dəyişiklik üçün tərəfdaşlıq» (ing. Partnering for Change) proqramı (CanChild) — məktəbə əsaslanan müdaxilə modeli — ergoterapevt müəllimlərlə birgə işləyir, sinif kontekstində uyğunlaşdırmalar həyata keçirir. Sübut: Missiuna C. və b. Int J Environ Res Public Health 2017.
7. Klaviatura təlimi və səs-mətn (voice-to-text) texnologiyası — akademik uyğunlaşdırma — əl yazısı çətinliyini kompensasiya edən köməkçi texnologiya.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- EACD 2019 (Blank və b. Dev Med Child Neurol 2019): CO-OP və NTT qəti tövsiyə edilir; sensor inteqrasiya terapiyası (Ayres SI) və bütöv bədən hərəkətinin təqlidi metodları üçün sübut zəif və ziddiyyətlidir.
- CanChild (ing. McMaster University): «Partnering for Change» — məktəb-əsaslı təlim modeli; müdaxilə təhsil sistemində birləşdirilir.
- NICE: ayrıca İHKP üzrə klinik göstəriş yoxdur; ümumi neyroinkişaf və xüsusi təhsil ehtiyacları (SEND) çərçivəsi daxilində.

9. Proqnoz

Yaxşı proqnoz amilləri

- Erkən identifikasiya və müdaxilə.
- CO-OP və ya NTT əsaslı sübuta əsaslanan müdaxilə tətbiq edilir.
- Komorbid DDHP, öyrənmə pozuntusu və narahatlığın idarə edilməsi nəzərə alınır.
- Ailə və məktəb dəstəyi.
- Normal intellektual səviyyə.

Pis proqnoz amilləri

- Çoxsaylı komorbid pozuntular (DDHP + LD + İHKP birgə).
- Sosial təcrid və idman fəaliyyətindən tam qaçınma.
- İkincili narahatlıq, depressiya və sosial fobiya inkişaf edə bilər.
- Gec identifikasiya.
- Müdaxilə qeyri-sübutlu metodlarla (yalnız Ayres sensor inteqrasiyası, Dore proqramı, Brain Gym).

İzləmə hədəfləri

- Motor funksional məqsədlərin hər 3–6 ayda bir yenidən qiymətləndirilməsi.
- Akademik nailiyyət və əl yazısı tempi monitorinqi.
- Sosial-emosional sağlamlıq — özünə hörmət, narahatlıq, depressiyanın skrininqi (yeniyetməlikdə xüsusilə vacibdir).
- Komorbidlik aktiv müalicəsi.
- Yetkinlikdə peşə uyğunlaşdırması — motor tələb edən iş yerlərindən qaçınma və ya uyğunlaşdırma planlaşdırması.
- Fiziki aktivlik və idman — sosial uyğunlaşma və ürək-damar sağlamlığı üçün; idman növü pasiyentin maraqlarına uyğunlaşdırılır (üzgüçülük, yoga kimi koordinasiya tələbi az olanlar).

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «Uşaq sadəcə tənbəldir/çox az çalışır»

Niyə yayılmışdır: motor çətinliyininin xarakter problemi kimi yanlış izah edilməsi; akademik müəssisələrdə motor pozuntularına məhdud bilik.

Klinik və bioloji məntiq: İHKP — neyroinkişaf pozuntusudur. Beyincik, bazal qanqliyalar, parietal qabıq funksional əlaqəsində qeyri-tipik modellər (Zwicker 2012 fMRI icmalı); «daxili modelləşdirmə» çatışmazlıq hipotezi — pasiyentin motor planlaşdırması və icrası üçün daha çox koqnitiv resurs sərf edir, yorulma və qaçınma davranışına səbəb olur.

Sübut: EACD 2019 (Blank və b.) — İHKP neyrobioloji əsaslı pozuntudur; «motivasiya problemi» yanlış izahdır.

Praktiki klinik addım: ailəyə və müəllimə bioloji əsaslar izah edilməli, ergoterapiya/fizioterapiya əsaslı CO-OP və ya NTT tətbiq edilməlidir.

Mif 2: «Uşaq böyüdükcə bunu aşacaq, öz-özünə aradan qalxacaq»

Sübut: Cantell M.H. və b. J Adolesc Res 2003, Kirby A. və b. Res Dev Disabil 2010 uzunmüddətli izləmə tədqiqatları — İHKP-li uşaqların 50–70%-i yetkinlikdə də motor çətinliklər saxlayır; akademik və peşə nəticələri, sosial uyğunlaşma zəifdir. Müdaxilə pəncərəsi məhdud deyil — istənilən yaşda effekt müşahidə oluna bilər, lakin erkən müdaxilə sosial-emosional nəticələri əhəmiyyətli yaxşılaşdırır.

Mif 3: «Valideyn səbirsizliyi və ya yanlış tərbiyə motor çətinliyinə səbəb olur»

Sübut: EACD, AAP — İHKP genetik və neyrobioloji əsaslıdır; valideyn tərbiyə təcrübəsi etioloji amil deyil. Erkən doğum, perinatal hipoksiya, ailə tarixçəsi əsas risk amilləridir.

10.2 Zərərli və ya elmi cəhətdən əsassız üsullar

Mif 4: «Sensory Integration Therapy (ing. Ayres SI) İHKP-ni sağaldır»

Niyə yayılmışdır: Jan Ayres 1972-ci ildə sensor inteqrasiya nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür; ergoterapiya praktikasında geniş yayılmışdır.

Sübut: EACD 2019 (Blank və b.) — Ayres SI yanaşmasının İHKP-də funksional motor performansa təsiri kifayət qədər sübut göstərmir; Smits-Engelsman 2013 meta-analiz — bottom-up sensor yanaşmalar top-down tapşırıq-yönəlmiş yanaşmalardan əhəmiyyətli dərəcədə zəifdir. AAP 2012 Sensory Integration Statement — terapevtik istifadə «tədqiqat mərhələsində olan» kimi təsnif edilir, birinci sıra tövsiyə edilmir.

Real klinik addım: top-down yanaşmalar (CO-OP, NTT) birinci sıra.

Mif 5: «Dore proqramı (ing. cerebellar exercise therapy) İHKP-ni sağaldır»

Sübut: Bishop D.V. Dyslexia 2007 sistemli tənqid — Reynolds-Nicolson orijinal tədqiqatlarının metodoloji məhdudiyyətləri; təkrar tədqiqatlarda effekt təsdiqlənməyib. EACD tövsiyə etmir.

Mif 6: «Brain Gym / Educational Kinesiology»

Sübut: Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007 — iddiaları neyrobiologiyaya uyğun gəlmir; motor və akademik nəticələrə təsiri sübut edilməyib.

Mif 7: «Vizual terapiya (göz məşqləri) İHKP-də motor koordinasiyasını yaxşılaşdırır»

Sübut: AAP, AAO və AAPOS-un 2009-cu il ortaq bəyanatı — göz hərəkəti terapiyasının motor koordinasiyasına və ya öyrənmə pozuntularına təsiri sübut edilməyib.

10.3 Səmərəsiz və ya əsas müdaxiləni təxirə salan üsullar

Mif 8: «EEG Neyrofidbek İHKP-də motor funksiyanı yaxşılaşdırır»

Sübut: spesifik İHKP üçün neyrofidbek sübut bazası məhduddur. EACD tövsiyə etmir; CO-OP və NTT-yə üstünlük verilir.

Mif 9: «Xüsusi pəhriz (omega-3 əlavələri) İHKP-ni yaxşılaşdırır»

Sübut: Richardson A.J. və b. Pediatrics 2012 (Oxford-Durham tədqiqatı) — omega-3 əlavələri İHKP-də motor funksiyanı yaxşılaşdırdığını iddia etmişdir, lakin sistemli icmallar (Cooper R.E. və b. J Psychopharmacol 2015) — kifayət qədər sübut əldə edilməmişdir. EACD tövsiyə etmir.

Mif 10: «Hiperbarik oksigen, kök hüceyrə inyeksiyaları, kraniosakral terapiya»

Sübut: heç birinin İHKP üçün effekt sübutu yoxdur; risk profili əhəmiyyətlidir.

Mif 11: «Çoxlu spor məşqi (intensiv idman) İHKP-ni keçirər»

Sübut: ümumi fiziki aktivlik faydalıdır, lakin İHKP-də motor öyrənmə çatışmazlıq spesifik strukturlaşdırılmış müdaxilə tələb edir. «Sadəcə daha çox məşq» rejimi pasiyentdə uğursuzluq və məyusluq yaradır. CO-OP və NTT kimi strukturlaşdırılmış yanaşmalar əhəmiyyətli dərəcədə üstündür.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və Xəstələnmə Statistikası üzrə Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A04 İnkişaf xarakterli motor koordinasiya pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. Vaşinqton: APA Publishing; 2022.
3. Blank R., Barnett A.L., Keyrni C., Qrin D., Kirbi A., Polatayko H. və b. İnkişaf koordinasiya pozuntusunun tərifi, diaqnostikası, qiymətləndirilməsi, müdaxiləsi və psixososial aspektləri üzrə beynəlxalq klinik tövsiyələr. «İnkişaf Təbabəti və Uşaq Nevrologiyası» (Dev Med Child Neurol). 2019;61(3):242–285.

4. Lingam R., Hant L., Qolding C., Conqmans M., Emond A. DSM-IV istifadə edilərək 7 yaşında inkişaf koordinasiya pozuntusunun yayılması: Böyük Britaniyada əhali əsaslı tədqiqat. «Pediatriya» (Pediatrics). 2009;123(4):e693–e700.
5. Kantell M.H., Smit M.M., Ahonen T.P. İnkişaf koordinasiya pozuntusu üçün iki fərqli yol: davamlılıq və həll olunma. «İnsan Hərəkəti Elmləri» (Hum Mov Sci). 2003;22(4–5):413–431.
6. Kirbi A., Edvards L., Sugden D., Rosenblum S. Yetkin İnkişaf Koordinasiya Pozuntuları/Dispraksiya Yoxlama Siyahısının (ADC) hazırlanması və standartlaşdırılması. «İnkişaf Əlilliyi Tədqiqatları» (Res Dev Disabil). 2010;31(1):131–139.
7. Zviker C.Q., Missiuna K., Harris S.R., Boyd L.A. İnkişaf koordinasiya pozuntusu: icmal və yenilənmə. «Avropa Pediatrik Nevrologiya Jurnalı» (Eur J Paediatr Neurol). 2012;16(6):573–581.
8. Adams İ.L.C., Lust C.M., Uilson P.H., Steenbergen B. DİP olan uşaqlarda hərəkət nəzarətinin pozulması: daxili modelin defisiti? «İnkişaf Təbabəti və Uşaq Nevrologiyası» (Dev Med Child Neurol). 2014;56(11):1043–1055.
9. Smits-Engelsman B.K., Blank R. van der Kay A.K. və b. DİP olan uşaqlarda hərəkət fəaliyyətini yaxşılaşdıran müdaxilələrin effektivliyi: birləşdirilmiş sistematik icmal və meta-analiz. «İnkişaf Təbabəti və Uşaq Nevrologiyası» (Dev Med Child Neurol). 2013;55(3):229–237.
10. Keyrni C., Veldhuizen S., Satmari P. Uşaqlarda hərəkət koordinasiyası və emosional-davranış problemləri. «Psixiatriyada Müasir Fikirlər» (Curr Opin Psychiatry). 2010;23(4):324–329.
11. Polatayko H.C., Mandiç A.D., Miller L.T., Maknab C.C. Gündəlik Fəaliyyət Fəaliyyətində Koqnitiv Oriyentasiya (CO-OP): II hissə — sübutlar. «Fizioterapiya, Fəaliyyət Terapiyası və Pediatriya» (Phys Occup Ther Pediatr). 2001;20(2–3):83–106.
12. Nimeyyer A.S., Smits-Engelsman B.K., Sxumaxer M.M. İnkişaf koordinasiya pozuntusu olan uşaqlar üçün nöromotor vəzifə təlimi: nəzarət edilən sınaq. «İnkişaf Təbabəti və Uşaq Nevrologiyası» (Dev Med Child Neurol). 2007;49(6):406–411.
13. Missiuna K., Pollok N., Levak D.E. və b. Dəyişiklik üçün Tərəfdaşlıq: inkişaf koordinasiya pozuntusu olan uşaqlar üçün məktəb əsaslı fəaliyyət terapiyası xidmətinin innovativ modeli. «Kanada Fəaliyyət Terapiyası Jurnalı» (Can J Occup Ther). 2012;79(1):41–50.
14. Bişop D.V.M. Motor koordinasiyanın məşqi ilə disleksiya və diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun müalicəsi: möcüzə, yoxsa mif? «Disleksiya» (Dyslexia). 2007;13(1):4–7.

15. Kuper R.E., Tay K., Kuntsi C., Vassos E., Asherson P. Omeqa-3 çoxdoymamış yağ turşusu əlavəsi və idrak: sistematik icmal və meta-analiz. «Psixofarmakologiya Jurnalı» (J Psychopharmacol). 2015;29(7):753–763.
16. Edvards C., Berub M., Erlandson K. və b. Çox erkən və/yaxud çox aşağı doğum çəkisi ilə doğulmuş məktəb yaşlı uşaqlarda inkişaf koordinasiya pozuntusu: sistematik icmal. «İnkişaf və Davranış Pediatriyası Jurnalı» (J Dev Behav Pediatr). 2011;32(9):678–687.

	6A05 DİQQƏT ÇATIŞMAZLIQ VƏ HİPERAKTİVLİK POZUNTUSU (DDHP)
XBT-11 **6A05**	**Attention deficit hyperactivity disorder**
XBT-10 F90.0	Aktivlik və diqqət pozuntusu
DSM-5-TR F90.0–F90.2	Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Diqqət Defisiti və Hiperaktivlik Pozuntusu (DDHP; XBT-11: 6A05; DSM-5-TR: 314.00–314.01) — erkən inkişaf dövründə (12 yaşa qədər) başlayan, diqqətsizlik, hiperaktivlik və impulsivlikdən ibarət davranış nümunəsi ilə xarakterizə edilən, akademik, sosial və ya peşə fəaliyyətində funksional pozulma yaradan neyroinkişaf pozuntusudur.

XBT-11-də və DSM-5-TR-də üç təqdimat forması mövcuddur:

- 6A05.0 — əsasən diqqətsiz təqdimat;
- 6A05.1 — əsasən hiperaktiv-impulsiv təqdimat;
- 6A05.2 — birləşmiş təqdimat.

2. Tarixçə

- Still G.F. (1902) — «əxlaqi nəzarətin anormal qüsuru» (ing. abnormal defect of moral control) — Goulston mühazirələrində (Lancet) ümumilikdə 43

uşağı təsvir etmişdir; onlardan 20-si (15 oğlan, 5 qız) intellektual inkişaf pozuntusu və fiziki xəstəlik olmadan bu qüsuru göstərmişdir.

- 1937 — Bradley C. — stimulyant (benzedrin) terapiyasının davranış problemləri olan uşaqlarda təsadüfi aşkarı.
- DSM-II (1968) — «Uşaqlıqda hiperkinetik reaksiya» (ing. Hyperkinetic Reaction of Childhood).
- DSM-III (1980) — «Diqqət defisiti pozuntusu» (hiperaktivliklə və ya hiperaktivlik olmadan; ing. attention deficit disorder) — diqqət defisitinin əsas əlamət kimi qəbul edilməsi.
- DSM-IV (1994) — «DDHP» termini və 3 alt-tip (diqqətsiz, hiperaktiv-impulsiv, birləşmiş) standartlaşdırılmışdır.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — «alt-tip» əvəzinə «təqdimat» (presentation) termini — vəziyyətin gedişi zamanı dəyişə bilməsini əks etdirir; başlanğıc yaşı 7-dən 12-yə qaldırılmışdır; yetkinlərdə diaqnoz üçün simptom sayı azaldılmışdır (hər kateqoriyada 9 simptomdan 6-sı əvəzinə 5-i; 17 yaş və yuxarı üçün).

3. Epidemiologiya

- Uşaqlarda yayılma 5–7% təşkil edir (Polanczyk G.V. və b. Am J Psychiatry 2007 sistemli icmal və meta-analiz, 102 tədqiqat). CDC ABŞ-da 3–17 yaşlı uşaqlarda valideyn hesabatına əsasən ömürlük diaqnoz 9,8% (NSCH 2016–2019), 2022 üçün 11,4%; bu klinik qiymətləndirmə deyil, əvvəllər qoyulmuş diaqnozun valideyn tərəfindən bildirilməsidir.
- Yetkinlərdə yayılma 2,5–4%-dir (Kessler R.C. və b. Am J Psychiatry 2006 — Komorbidliyin Milli Tədqiqi proqramı (ing. National Comorbidity Survey Replication)).
- Cinsə görə: uşaqlıqda oğlanlarda bu göstərici 2–4 dəfə yüksəkdir (qadınlarda diaqnozun az qoyulması — daha az hiperaktivlik, daha çox diqqətsizlik); yetkinlikdə fərq azalır.
- Persistensiya: təxminən 60–70% uşaqlıq DDHP-si yetkinlikdə müəyyən səviyyədə davam edir (Faraone S.V. və b. Psychol Med 2006 meta-analiz).
- Komorbidlik: müxalif-inadkar pozuntu (MİP) 40%, davranış pozuntusu 14%, narahatlıq 25%, depressiya 15–30%, öyrənmə pozuntusu 25–40%, tik pozuntuları 7–20%, autizm spektri pozuntusu olan pasiyentlərdə 30–50%, maddə istifadəsi pozuntusu riski yeniyetməlik və yetkinlikdə 2–3 dəfə artır.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

- İrsilik: 74% (Faraone S.V., Larsson H. Mol Psychiatry 2019 əkiz və ailə tədqiqatları meta-analizi) — irsiyyət göstəricisi ən yüksək olan neyroinkişaf pozuntularından biri.
- Genetik quruluş: poligen xarakter daşıyır — yüzlərlə kiçik təsirli variant. GWAS (Demontis D. və b. Nat Genet 2019, n>55 000) 12 risk lokusu aşkar etmişdir (FOXP2, SORCS3, DUSP6 və başqaları).
- Dopamin sisteminin genləri — DRD4, DRD5, DAT1 (SLC6A3) — kandidat genlər hesab edilir; effekt ölçüsü kiçikdir.
- CNV — nadir hallarda; ümumi varyasiyalar əsasdır.

4.2 Neyrobioloji mexanizmlər

- Dopaminergik və noradrenergik sistemlərin disfunksiyası — xüsusilə prefrontal qabıq, striatum, beyincik dövrəsi; stimulyantlar bu sistemlərə təsir edərək simptomları azaldır.
- Struktur dəyişikliklər: ümumi beyin və xüsusi sahə (kaudat, putamen, prefrontal qabıq) həcmində azalma (Hoogman M. və b. Lancet Psychiatry 2017 ENIGMA-DDHP n>3000 — kiçik effekt ölçüləri).
- Funksional əlaqə: defolt rejim şəbəkəsi (default mode network) və icra nəzarəti şəbəkəsi (ing. executive control network) arasında dizrequlyasiya.
- İcra funksiyası modeli (Barkley R.A.) — inhibisiyanın zəifliyi əsas çatışmazlıq; işləyən yaddaş (ing. working memory), öncədən planlaşdırma, emosional tənzimləməyə təsir edir.
- Mükafat sistemi disfunksiyası — gecikmiş mükafata qarşı həssaslıq (Sonuga-Barke E.J. Neurosci Biobehav Rev 2003).

4.3 Mühit risk amilləri

- Erkən doğum və aşağı doğum çəkisi — riski 2–3 dəfə artırır.
- Anada hamiləlikdə tütün, alkohol, kannabis istifadəsi.
- Anada perinatal stress və ağır psixososial məhrumiyyət.
- Uşaqlıqda qurğuşun ekspozisiyası risk faktoru hesab edilir.
- Erkən kəllə-beyin travması (KBT).

4.4 4.4 Etiologiya miflərinə dair dəqiq mövqe

- Şəkər DDHP yaratmır (Wolraich M.L. və b. JAMA 1995 meta-analiz).

- Ekran vaxtı / videooyunlar DDHP-ni yaratmır (assosiasiya mövcuddur, lakin səbəb-nəticə əlaqəsini göstərən sübut yoxdur — Ferguson C.J. Perspect Psychol Sci 2015).
- Pis tərbiyə DDHP-ni yaratmır (irsilik 74%); lakin münaqişəli ailə mühiti simptom şiddətinə təsir göstərə bilər.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Diqqətsizlik sahə

- Detallara diqqət etməmə, ehtiyatsız səhvlər.
- Tapşırıqlarda diqqəti saxlamaq çətinliyi.
- Birbaşa danışıldıqda dinləməmiş kimi görünmə.
- Təlimatlara tam əməl etməmə, tapşırıqları yarımçıq qoyma.
- Tapşırıq və fəaliyyətləri təşkil etmək çətinliyi.
- Davamlı zehni səy tələb edən tapşırıqlardan qaçınma.
- Lazımi əşyaları itirmə.
- Xarici stimullar tərəfindən asanlıqla yayındırılma.
- Gündəlik fəaliyyətlərdə unutqanlıq.

5.2 Hiperaktivlik və impulsivlik sahə

- Əllərin və ayaqların hərəkəti, oturduğu yerdə qıvrılma.
- Sakit oturmağı tələb edən yerlərdə oturmama.
- Uyğun olmayan yerlərdə qaçma və ya dırmaşma (yetkinlərdə daxili narahatlıq hissi).
- Sakit fəaliyyətdə oynaya bilməmə.
- «Mühərriklə hərəkətə gətirilmiş kimi» davranış.
- Həddsiz danışma.
- Sual tamamlanmamışdan əvvəl cavab verməyə tələsmə.
- Növbəni gözləyə bilməmə.
- Başqalarının söhbətinə və ya fəaliyyətinə müdaxilə etmə.

5.3 Yaş üzrə fərqlər

- Məktəbəqədər yaş: hiperaktivlik üstünlük təşkil edir; oyunda diqqət qısa olur; sosial vəziyyətlərdə davranışa nəzarət çətindir.
- Məktəb yaşı: akademik problemlər önə çıxır; diqqətsizlik akademik nailiyyətə təsir edir.

- Yeniyetməlik: hərəkət hiperaktivliyi azalır, daxili narahatlıq və impulsivlik qalır; risk davranışı artır.
- Yetkinlik: daxili narahatlıq, planlaşdırma çətinliyi, münasibətlərdə impulsivlik; iş və ailə həyatında funksional pozulma.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11, NICE NG87, AAP 2019 konsensus nöqtələri)

A. Diqqətsizlik və ya hiperaktivlik-impulsivlik üzrə uşaqlarda (≤16 yaş) hər kateqoriyada ən az 6 simptom, yetkinlərdə (17+) ən az 5 simptom, ən azı 6 ay davam etmiş və inkişaf səviyyəsinə uyğun olmayan dərəcədə olmalıdır.

B. Bir neçə simptom 12 yaşa qədər mövcud olmalıdır.

C. Simptomlar ən azı iki mühitdə (məs. ev + məktəb, ev + iş) müşahidə edilməlidir.

D. Funksional pozulma — sosial, akademik, peşə fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsir.

E. İstisnalar — şizofreniya və ya digər psixotik pozuntu kontekstində baş vermir; başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR (314.00–314.01; F90.0–F90.2): təqdimat — diqqətsiz, hiperaktiv-impulsiv və birləşmiş; şiddət — yüngül, orta, ağır. Başlanğıc yaşı 12-yə qaldırılmışdır (DSM-IV-də 7).
- XBT-11 (6A05): paralel struktur; komorbidlik kvalifikatorları (autizm, dil pozuntusu, intellektual inkişaf pozuntusu).
- NICE NG87 (2018, yenilənmə 2019): diaqnoz multidissiplinar qrup tərəfindən (uşaqlarda — pediatr/psixiatr; yetkinlərdə — psixiatr); strukturlaşdırılmış müsahibə və müşahidə birlikdə tətbiq edilməlidir.
- AAP 2019 (Wolraich M.L. və b. Pediatrics 2019;144(4)): ilkin tibbi yardım səviyyəsində 4–18 yaş üçün diaqnostika və müalicə alqoritmi; 4–5 yaş — birinci sıra valideyn təlimi (valideyn-uşaq qarşılıqlı əlaqə terapiyası, PCIT, valideyn idarəetmə təlimi), ikinci sıra metilfenidat; 6–11 yaş — birinci sıra stimulyant + davranış müdaxiləsi; 12–18 yaş — birinci sıra stimulyant + davranış müdaxiləsi (yeniyetmənin razılığı ilə).
- AACAP Practice Parameter (Pliszka S. JAACAP 2007): komorbidlik qiymətləndirməsi və müalicə ardıcıllığı.

- CADDRA Canadian DDHP Practice Guidelines (4-cü nəşr, 2018): yetkin DDHP üçün əhatəli alqoritm.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Valideyn və müəllim (uşaqlar üçün) və ya Uşaqlar üçün valideyn və müəllimlə, yetkinlər üçün isə pasiyentin özü ilə müsahibə — simptom tarixçəsi, başlanğıc yaşı, kontekstlər.
2. Standartlaşdırılmış qiymətləndirmə şkalaları — Conners-3 (valideyn/müəllim/pasiyent), Vanderbilt (AAP tövsiyəsi), SNAP-IV; yetkinlər üçün ASRS (ing. Adult ADHD Self-Report Scale, WHO/Kessler).
3. Klinik müsahibə — simptomların iki kontekstdə təsdiqi, funksional pozulma sənədləşməsi.
4. Tibbi və neyroloji müayinə — somatik səbəblər (tiroid, eşitmə, görmə, anemiya) istisna.
5. İntellektual və akademik qiymətləndirmə (WISC-V, akademik testlər) — öyrənmə pozuntusu və intellektual əlillik fərqliliyi.
6. Komorbidlik skrininq — MİP, davranış pozuntusu, narahatlıq, depressiya, tikli, autizm, maddə istifadəsi.
7. Yuxu pozuntusu və obstruktiv yuxu apnoesi üçün skrininq aparılmalıdır (xüsusilə hiperaktiv-impulsiv tipdə).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Yaş və inkişaf — normal variasiya	Funksional pozulma yoxdur və ya həmin davranış iki kontekstdə müşahidə edilmir.
Müxalif-inadkar pozuntu (6C90)	Tabesizlik və qəzəb əsas əlamətlərdir; komorbidlik sıx olur.
Davranış pozuntusu (6C91)	Ciddi davranış pozuntuları, başqalarının hüquqlarına təcavüz.
Təşviş pozuntuları (6B00–6B0Z)	Diqqətsizlik narahatlıqdan qaynaqlanır; somatik şikayətlər müşahidə edilir; başlanğıc ümumiyyətlə gecdir.
Depressiv pozuntu (6A70–6A7Z)	Affektiv simptomlar üstünlük təşkil edir; episodik gediş.

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Bipolyar pozuntu (6A60–6A6Z)	Affektiv epizodlar; uşaqlıq DDHP-də manik epizod olmur.
Autizm spektri pozuntusu (6A02)	Sosial-kommunikativ çatışmazlıq, məhdud-təkrarlanan davranışlar. Komorbid sıxdır.
Öyrənmə pozuntusu (6A03)	Akademik sahə-spesifik çatışmazlıq; diqqət problemləri tapşırıq kontekstinə bağlıdır.
Obstruktiv yuxu apnoesi	Gündüz yuxululuğu, davranış problemləri; polisomnoqrafiya.
Hipertireoz	TSH səviyyəsi aşağı olur; titrəmə və çəki itkisi müşahidə edilir.
Absans (petit mal) epilepsiyası	Qısa şüur dəyişiklikləri; EEQ-də 3 Hs tezlikli pik-dalğa kompleksi.
Eşitmə pozuntusu	Audiometriya nəticələri pozulmuş olur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik şkalalar

- Vanderbilt DDHP Diagnostic Rating Scale — valideyn və müəllim, 6–12 yaş — AAP 2019 tövsiyəsi.
- Conners-3 — kompleks DDHP və komorbidlik qiymətləndirməsi (6–18 yaş).
- SNAP-IV (Swanson, Nolan, Pelham) — 26 sual.
- ASRS (Yetkin DDHP Özünühesabat Şkalası; ÜST/Kessler R.C.) — 18 sual; yetkin pasiyentlərdə qısa skrininq.
- DIVA-5 (Yetkinlərdə DDHP üçün diaqnostik müsahibə; ing. Diagnostic Interview for ADHD in Adults) — strukturlaşdırılmış müsahibə.
- BRIEF-2 (ing. Behavior Rating Inventory of Executive Function) — icra funksiyası.

7.2 Laborator müayinələr

Rutin DDHP üçün spesifik laborator göstəriş yoxdur. Klinik şübhə əsasında:

- Ümumi qan analizi, ferritin (dəmir çatışmazlığı), tiroid funksiyası (TSH).

- Qurğuşun səviyyəsi risk amilləri olduqda müəyyən edilir.
- Toksikoloji skrininq yeniyetmələrdə maddə istifadəsi şübhəsi olduqda aparılır.
- Stimulyant müalicəsinə başlamazdan əvvəl — EKG yalnız ürək riski tarixçəsi və ya ailə tarixçəsi varsa (AAP, ABŞ Ürək Assosiasiyası (AHA) 2008; rutin EKQ tələb edilmir).

7.3 İnstrumental müayinələr

- EEQ yalnız tutma şübhəsi və ya atipik klinik təzahürlər olduqda təyin edilir.
- Beynin MRE müayinəsi yalnız fokus neyroloji əlamətlər olduqda aparılır. Rutin göstəriş yoxdur.
- Diaqnostika üçün neyrofizioloji testlər (TOVA, IVA, QbTest) kifayət qədər sübut bazasına malik deyillər — klinik diaqnoz və standartlaşdırılmış şkalalara qızıl standart kimi üstünlük verilir.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE NG87, AAP 2019, CADDRA 2018 konsensusu)

1. Yaş əsaslı yanaşma (AAP 2019):
    - 4–5 yaş — birinci sıra valideyn təlimi (PCIT, Triple P, «İnanılmaz illər» (Incredible Years)); ikinci sıra metilfenidat.
    - 6–11 yaş — birinci sıra stimulyant + davranış müdaxiləsi.
    - 12–18 yaş — birinci sıra stimulyant + davranış müdaxiləsi; yeniyetmənin razılığı.
    - Yetkinlər — stimulyant və ya qeyri-stimulyant + KDT.
2. Multimodal müdaxilə tək farmakoterapiya və ya tək davranış müdaxiləsindən üstündür (MTA Cooperative Group. Arch Gen Psychiatry 1999, n=579 — kombinasiya bəzi nəticələr üzrə monoterapiyadan üstün olmuşdur, lakin farmakoterapiya tək davranış müdaxiləsindən daha güclü).
3. Stimulyantlar — birinci sıra farmakoterapiya (Cortese S. və b. Lancet Psychiatry 2018 şəbəkə meta-analizi; uşaqlarda metilfenidat birinci seçim, yetkinlərdə amfetamin daha effektiv).
4. Qeyri-stimulyantlar — atomoksetin, guanfasin (uzunmüddətli formada), klonidin (uzunmüddətli formada). Stimulyant əks-göstəriş olduqda və ya yan təsir yaratdıqda istifadə edilir.
5. Davranış müdaxiləsi — valideyn təlimi (PCIT, valideyn idarəetmə təlimi), məktəb əsaslı müdaxilə (sinif modifikasiyaları, davranış müqaviləsi), uşaq KDT.

6. Akademik akkomodasiya — fərdi təhsil planı (fərdi təhsil planı, IEP; ABŞ-da 504-cü plan; EHCP — xüsusi təhsil ehtiyacları planı, Böyük Britaniya); əlavə vaxt, məhdud yayındırıcılar, yazılı deyil, şifahi cavab variantları.
7. Yan təsirlərin izlənməsi — boy və çəki, qan təzyiqi, ürək nəbzi (3 aylıq), yuxu, iştaha, əhval. Stimulyantlarda boy artımının kiçik dərəcədə azalması (1–2 sm uzunmüddətli istifadədə) gözlənilir.
8. Komorbidlik müalicəsi — təşviş və depressiya (SSGİ + KDT), tik pozuntuları (α2-adrenergik aqonistlər və ya ehtiyatla stimulyant), maddə istifadəsi (lisdeksamfetamin və ya atomoksetin — sui-istifadə potensialı aşağıdır), autizm (komorbid qıcıqlanma üçün atipik antipsixotik).

8.2 Stimulyantlar (birinci sıra farmakoterapiya)

Preparat	Forma	Doza diapazonu	Qeyd
Metilfenidat IR	Qısamüddətli (3–4 saat)	5–60 mq/gün (2–3 doza)	Uşaqlarda titrasiya başlanğıcı; Cortese 2018 — uşaqlarda birinci sıra.
Metilfenidat ER (uzadılmış buraxılış forması; Concerta, Ritalin LA — uzun təsirli formalar)	Uzunmüddətli (8–12 saat)	18–72 mq/gün	Bir dəfəlik gündəlik doza; məktəb gününə əlverişli.
Lisdeksamfetamin (Vyvanse)	Ön-dərman (prodrug), 12+ saat	20–70 mq/gün	Sui-istifadə potensialı aşağıdır (ön-dərman); yetkinlərdə üstün.
Qarışıq amfetamin duzları (Adderall XR)	Uzunmüddətli (10–12 saat)	5–30 mq/gün	Yetkinlərdə Cortese 2018 — I sıra.
Deksamfetamin	IR (4 saat) / ER (8 saat)	5–40 mq/gün	—

8.3 Qeyri-stimulyantlar

Preparat	Mexanizm	Doza	Qeyd
Atomoksetin (Strattera)	Noradrenalin geri-götürülmə inhibitoru	0,5–1,4 mq/kq/gün	Effekt 4–6 həftədən sonra müşahidə edilir; intihar fikirləri riskinin yüngül artımı (FDA qara çərçivə xəbərdarlığı).
Guanfasin ER (Intuniv)	α2A adrenergik aqonist	1–7 mq/gün	Sedasiya, hipotenziya; tik pozuntusu komorbid olduqda faydalıdır.
Klonidin ER (Kapvay)	α2 adrenergik aqonist	0,1–0,4 mq/gün	Sedasiya; yuxu pozuntusu komorbid olduqda.
Viloksazin ER (Qelbree)	noradrenalin geri-götürülmə inhibitoru + serotoninergik modulator	uşaqlarda 100–400 mq/gün, yetkinlərdə 200–600 mq/gün	FDA 2021; 6 yaşdan yuxarı uşaqlar və yetkinlər üçün təsdiq edilmişdir.

8.4 Müalicə metodikaları

1. Valideyn-Uşaq Qarşılıqlı Təsir Terapiyası (PCIT; ing. Parent-Child Interaction Therapy) — Eyberq (Eyberg S.) — 4–7 yaşlı uşaqlar üçün; iki mərhələ — uşaq yönümlü qarşılıqlı təsir (CDI) və valideyn yönümlü qarşılıqlı təsir (PDI). Terapevtin real vaxt rejimində təlimatlandırması (ing. in vivo coaching) ilə valideynin davranış idarəsi bacarıqlarının inkişafı. https://www.pcit.org
2. «İnanılmaz illər» (ing. Incredible Years) proqramı — Vebster-Stratton (Webster-Stratton C.) — Valideyn, müəllim və uşaq proqramları; qrup formatında 14–22 seans; nüfuzlu, stimullaşdırıcı və etibarlı valideynlik üslubu modeli (ing. Authoritative Stimulating Trustworthy Parenting Style).
3. Triple P — Müsbət Valideynlik Proqramı (ing. Positive Parenting Program) — Sanders (Sanders M.) — Avstraliyada yaradılmış 5 pilləli sistem — universal, seçici, hədəfli, fərdi. Çoxsaylı RKİ-lərdə effekt sübutlu.

4. Valideyn İdarəetmə Təlimi (ing. Parent Management Training) — Barkli (Barkley) — 8–12 seans davranış prinsipləri əsaslı valideyn təlimi — işarə əsaslı mükafatlandırma sistemi (token), müvəqqəti təcrid (time-out), davamlı təlim.
5. Yetkin DDHP üçün KDT (ing. Safren CBT for Adult ADHD) — Safren (Safren S.A.) — Yetkin DDHP üçün KDT modulları — vəzifə təşkilatı, planlaşdırma, yayındırıcı idarə, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma. Sübut: Safren S.A. və b. JAMA 2010 RKİ.
6. Vanderbilt DDHP Diaqnostik Qiymətləndirmə Şkalası — AAP 2019 tərəfindən tövsiyə edilir; (ing. Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale) — AAP 2019 tərəfindən tövsiyə edilən; valideyn və müəllim formaları, komorbidlik altşkalaları.
7. Yetkin DDHP Özünühesabat Şkalası (ing. Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS) — Kessler (Kessler R.C.), ÜST — 18 sual; qısa 6 maddəlik skrininq bölməsi. Yetkin pasiyentlərdə klinik və əhali skrininq.
8. Yetkinlərdə DDHP üçün Diaqnostik Müsahibə (DIVA-5; ing. Diagnostic Interview for ADHD in Adults) — DSM-5-TR meyarları üzrə strukturlaşdırılmış müsahibədir — DSM-5-TR meyarları üzrə.
9. Conners-3 şkalası (bax 7.1) 6–18 yaşda kompleks qiymətləndirmə aparmağa imkan verir: — DDHP simptomları, icra funksiyası, davranış pozuntusu, öyrənmə.
10. İcra funksiyalarının davranış qiymətləndirmə anketi (BRIEF-2) (ing. Behavior Rating Inventory of Executive Function, BRIEF-2) — İcra funksiyasının valideyn və müəllim qiymətləndirməsi — inhibisiya, işləyən yaddaş, emosional tənzimləmə.
11. EEQ neyrofidbek (ing. EEG neurofeedback) — DDHP-də spesifik beyin dalğa nümunələrinin (teta/beta nisbəti) öz-tənzimlənmə təlimi. Sübut: Holtmann M. və b. Dev Med Child Neurol 2011 meta-analiz — kiçik effekt ölçüsü; sahə mütəxəssisləri arasında effekti mübahisəli. NICE NG87-yə görə bu metod birinci sıra deyil, köməkçi (adjunkt) status daşıyır.

8.5 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG87 (2018, yenilənmə 2019): 5+ yaş — mühit amillərinin dəyişdirilməsi ilk addımdır; sonra davranış və ya farmakoterapiya. Yetkinlərdə — birinci sıra stimulyant; ikinci sıra atomoksetin.
- AAP 2019 (Wolraich): yaş əsaslı alqoritm yuxarıda təsvir edilib.
- Cortese S. və b. Lancet Psychiatry 2018 (şəbəkə meta-analizi): uşaqlar — metilfenidat birinci sıra; yetkinlər — amfetamin birinci sıra (effekt ölçüsü daha yüksək); atomoksetin orta effektivliyə malikdir.

- MTA Cooperative Group (Arch Gen Psychiatry 1999, izləmə Hechtman L. və b. JAACAP 2016): kombinasiyalı müalicənin 14 aylıq müşahidədə üstünlüyünü göstərmişdir; lakin 36 aylıq və 8 illik izləmədə fərqlər zəifləyir — uzunmüddətli effekt mübahisəlidir.
- FDA və EMA monitorinq tələbləri: boyun və çəkinin izlənməsi, ürək-damar göstəricilərinə nəzarət.

9. Proqnoz

9.1 Yaxşı proqnoz amilləri

- Erkən identifikasiya və müdaxilə.
- Yüksək IQ — kompensator strategiyalar.
- Stabil və dəstəkləyici ailə mühiti.
- Komorbid pozuntuların aktiv müalicəsi.
- Stimulyant və davranış müdaxiləsinə yaxşı cavab.
- Yeniyetməlik və yetkinlikdə müalicəyə riayətin saxlanılması.

9.2 Pis proqnoz amilləri

- Komorbid davranış pozuntusu, oppozisional davranış pozuntusu.
- Aşağı sosial-ekonomik dəstək.
- Yeniyetməlikdə maddə istifadəsinin inkişafı.
- İcra funksiyası defisitinin ağırlığı.
- Gec identifikasiya.
- Sübut bazası olmayan metodlarla müdaxilə.

9.3 İzləmə hədəfləri

- Simptomların və funksional nəticələrin izlənməsi (3–6 ayda bir).
- Stimulyant qəbul edənlərdə boy, çəki, qan təzyiqi və nəbz 3 ayda bir izlənilməlidir.
- Komorbid təşviş, depressiya və maddə istifadəsi üzrə skrininq aparılmalıdır.
- Akademik və peşə nailiyyət dəstəyi.
- Yeniyetməlikdə risk davranışı avtomobil idarəetməsi təlimi, cinsi sağlamlıq və maddə istifadəsi üzrə müdaxilə.
- Yetkinlikdə peşə uyğunlaşması, münasibətlər, maliyyə planlaşdırması — DDHP-yə uyğunlaşdırılmış KDT.

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «DDHP uydurma diaqnozdur, uşaqlar sadəcə fəaldır»

Yayılma səbəbləri: normal uşaq enerjisinin patoloji kimi yanlış qəbul edilməsi narahatlığı; bəzi diaqnozun həddindən artıq genişlənməsi halları qeyd edilir.

Klinik və bioloji məntiq: DDHP davamlı və ölçülə bilən neyrobioloji əlamətlərə malikdir — irsilik 74% (Faraone & Larsson 2019), beyin struktur (Hoogman ENIGMA-DDHP 2017) və funksional fərqlər; stimulyantların xüsusi mexanizmə təsiri (dopamin-noradrenalin) farmakoloji sübutdur. Diaqnozun qoyulmaması (xüsusilə qadınlarda) həddindən artıq diaqnozdan daha geniş yayılmış problemdir.

Sübut: APA, AAP, ÜST (WHO), NIMH — DDHP bioloji əsaslı pozuntudur; CDC ABŞ-da valideyn hesabatına əsaslanan yayılma 3–17 yaşda 9,8% (2016–2019) və 11,4% (2022), beynəlxalq əhali tədqiqatları meta-analizi 5–7% (Polanczyk 2007).

Real klinik addım: dəqiq diaqnostika strukturlaşdırılmış meyarlarla; funksional pozulma tələb edilir (sadə davranış variasiyası deyil).

Mif 2: «Şəkər DDHP-ni yaradır və ya simptomları gücləndirir»

Niyə yayılıb: şəkərin uşaq enerjisini artırma intuisiyası; «Feingold pəhrizi» 1970-ci illərdə populyarlaşmışdır.

Sübut: Wolraich M.L. və b. JAMA 1995 sistemli icmal və meta-analiz — şəkərin uşaq davranışına və koqnitiv performansına təsiri aşkar edilməmişdir. Wolraich M.L. və b. NEJM 1994 — plasebo nəzarətli RKİ.

Praktik klinik addım: ümumi sağlam pəhriz, lakin şəkərin məhdudlaşdırılması DDHP müdaxiləsi kimi tövsiyə edilmir.

Mif 3: «Pis tərbiyə DDHP-ni yaradır»

Sübut: irsiyyət payı 74%-dir (Faraone & Larsson Mol Psychiatry 2019); valideyn təcrübəsi etiologiya deyil. Bununla belə, yüksək konfliktli mühit simptomların şiddətinə təsir göstərə bilər. Valideyn təlimi (valideyn-uşaq qarşılıqlı təsir terapiyası — PCIT; Triple P) effektivdir, çünki davranışın idarə edilməsi bacarıqlarını gücləndirir — günahlandırma deyil, dəstək məqsədilə.

Mif 4: «Ekran vaxtı və kompüter oyunları DDHP-ni yaradır»

Sübut: assosiasiya mövcuddur, lakin səbəbiyyət istiqaməti mübahisəlidir — DDHP-li uşaqlar ekran fəaliyyətinə daha çox cəlb olunur (əks istiqamətli səbəbiyyət — reverse

causation); Ferguson C.J. Perspect Psychol Sci 2015 icmal — kompüter oyunlarının DDHP yaratması sübut edilməmişdir. Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) — ekran vaxtının məhdudlaşdırılması ümumi sağlamlıq üçün tövsiyə edilir, lakin DDHP-nin «səbəbi» kimi tövsiyə edilmir.

10.2 Zərərli «müalicə» üsulları və yanlış inanclar

Mif 5: «Stimulyantlar narkotik kimi asılılıq yaradır və gələcəkdə narkomaniyaya səbəb olur»

Niyə yayılmışdır: metilfenidat və amfetaminlərin maddə cədvəlində (Schedule II ABŞ-da) olması; «narkotik» qorxusunun ümumi yayılması.

Klinik və bioloji məntiq: Terapevtik dozada oral stimulyant tədricən beyində terapevtik konsentrasiyaya çatır (1–2 saat) — eyforik effekt minimal olur. İntravenoz və ya intranazal istifadə (sui-istifadə yolları) ilə fərqli farmakokinetika baş verir.

Sübut: Wilens T.E. və b. Pediatrics 2003 meta-analiz, n=1034 — stimulyantla müalicə edilmiş DDHP-li yeniyetmələrdə yetkinlikdə maddə istifadəsi azalır, artmır (riskin azalması təxminən 50%). Lisdeksamfetamin və osmotik buraxılışlı metilfenidat (osmotic-release metilfenidat, Concerta) — sui-istifadə potensialı aşağıdır (pro-dərman strukturu — prodrug; osmotik buraxılış sistemi — OROS).

Praktik klinik addım: komorbid maddə istifadəsi olduqda — lisdeksamfetamin və ya atomoksetin üstündür; pasiyent və ailəyə təhlükəsizlik təlimi.

Mif 6: «Stimulyantlar uşağın boy artımını və beyin inkişafını dayandırır»

Sübut: MTA Cooperative Group izləmə (Swanson J.M. və b. JAACAP 2017) — stimulyantla müalicə edilmiş uşaqlarda yetkin boy 1–2 sm aşağı (gözlənilən yetkin boyla müqayisədə); bu kiçik və klinik baxımdan əhəmiyyətsiz hesab olunur. Beyin inkişafı — stimulyantlarla bağlı zərər sübutu yoxdur (Schweren L.J.S. və b. Neuropsychopharmacology 2015 icmal).

Mif 7: «Kanabis DDHP-ni sağaldır»

Sübut: NIDA, NICE — kanabis DDHP müalicəsi üçün təsdiqlənməmişdir; psixoz riskini artırır (Marconi 2016), koqnitiv pozulmaya səbəb olur, motivasiyanı azaldır. Subyektiv «sakitləşdirici» effekt funksional pozulmanı maskalayır.

10.3 Səmərəsiz və ya elmi cəhətdən əsassız üsullar

Mif 8: «Feingold pəhrizi və ya qida rəngləyiciləri və əlavələrindən imtina DDHP-ni sağaldır»

Sübut: Pelsser L.M. və b. Lancet 2011 (INCA tədqiqatı) — məhdudlaşdırıcı eliminasiya pəhrizi (ing. restrictive elimination diet) bəzi uşaqlarda davranışa təsir göstərə bilər (təxminən 30%), lakin sistemli icmallar (Sonuga-Barke E.J. və b. Am J Psychiatry 2013 meta-analiz) — qida əlavələrindən imtinanın effekt ölçüsü kiçikdir, yalnız valideynlər tərəfindən qiymətləndirməyə üstün təsir göstərir, kor (maskalanmış) yoxlama olduqda zəifləyir. AAP, NICE — birinci sıra deyil; kompleks pəhrizin qida çatışmazlığı riski mövcuddur.

Mif 9: «Omeqa-3 əlavələri DDHP-nin əsas müalicəsidir»

Sübut: Cooper R.E. və b. J Psychopharmacol 2015 və Bloch M.H., Qawasmi A. JAACAP 2011 meta-analizləri — kiçik effekt ölçüsü ($g \approx 0{,}3$); stimulyantlardan ($g \approx 1{,}0$) əhəmiyyətli dərəcədə zəifdir. Köməkçi müalicə (adjunkt) rol oynaya bilər; əsas müalicə deyil.

Mif 10: «Elektroensefaloqrafiya (EEQ) əsaslı neyroəlaqə stimulyantı əvəzləyir»

Sübut: Holtmann M. və b. Dev Med Child Neurol 2011 və Cortese S. və b. JAACAP 2016 meta-analiz — neyrofidbek effekti iştirakçı (proband) və müəllim tərəfindən qiymətləndirildikdə əhəmiyyətli azalır; kor (blinded) qiymətləndirmədə effekt ölçüsü kiçikdir. NICE NG87 — birinci sıra deyil. Stimulyantların effekt ölçüsü əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür.

Mif 11: «İdmanla məşğul olmağa məcbur etmək uşağın DDHP-ni sağaldar»

Sübut: fiziki aktivlik DDHP-də simptomları bir qədər azaltmağa kömək edə bilər (əlavə müalicə kimi — adjunkt); lakin əsas müdaxiləni əvəzləmir. AAP — strukturlaşdırılmış fiziki aktivlik tövsiyə edir, lakin təkbaşına müalicə üsulu deyil.

Mif 12: «Kraniosakral terapiya, kiropraktika, homeopatiya DDHP-ni sağaldır»

Sübut: Cochrane və sistemli icmallar — bu komplementar müdaxilələrin DDHP üçün effektivliyi sübut edilməmişdir.

Mif 13: «İşıq terapiyası, mavi işığı süzən (MUS) rəngli linzalar DDHP-ni sağaldır»

Sübut: elmi əsas yoxdur. AAP, AAO mövqeyi — sübutlu deyil.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və xəstələnmə statistikası üzrə Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A05 Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Diaqnostik və Statistik Rəhbərlik, 5-ci nəşr, mətnin yenidən baxılmış variantı (DSM-5-TR). Vaşinqton: APA Publishing; 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NICE Klinik Təlimatı NG87. Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusu: diaqnostika və idarəetmə. 2018, 2019-cu ildə yenilənmişdir.
4. Volrayç M.L., Haqan C.F., Allan K. və b. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun diaqnostikası, qiymətləndirilməsi və müalicəsi üzrə Klinik Təcrübə Təlimatı. «Pediatriya» (Pediatrics). 2019;144(4):e20192528.
5. Pliszka S., Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyası (AACAP) Keyfiyyət Məsələləri üzrə İş Qrupu. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun qiymətləndirilməsi və müalicəsi üzrə Təcrübə Parametri. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2007;46(7):894–921.
6. Kanada Diqqət Çatışmazlığı Hiperaktivlik Pozuntusu Resurs Alyansı (CADDRA). Kanada DİP Təcrübə Təlimatları, 4-cü nəşr. CADDRA; 2018.
7. Kortese S., Adamo N., Del Covane K. və b. Uşaqlarda, yeniyetmələrdə və böyüklərdə diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun dərmanlarının müqayisəli effektivliyi və tolerantlığı: sistematik icmal və şəbəkə meta-analizi. «Lancet Psixiatriyası» (Lancet Psychiatry). 2018;5(9):727–738.
8. Multimodal Müalicə Tədqiqatı üzrə Əməkdaşlıq Qrupu (MTA). Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun müalicə strategiyalarının 14 aylıq randomizə edilmiş klinik sınağı. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 1999;56(12):1073–1086.
9. Heçtman L., Svanson C.M., Siblinq M.H. və b. Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun uşaqlıqda diaqnozundan 16 il sonra funksional yetkinlik nəticələri: MTA nəticələri. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2016;55(11):945–952.
10. Polançik Q. de Lima M.S., Horta B.L., Biderman C., Rohde L.A. DİP-in dünya üzrə yayılması: sistematik icmal və metareqressiya analizi. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2007;164(6):942–948.

11. Faraone S.V., Larsson H. Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun genetikası. «Molekulyar Psixiatriya» (Mol Psychiatry). 2019;24(4):562–575.
12. Demontis D., Volters R.K., Martin C. və b. Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusu üçün ilk genom üzrə əhəmiyyətli risk lokuslarının aşkarlanması. «Təbiət Genetikası» (Nat Genet). 2019;51(1):63–75.
13. Hoqman M., Bralten C., Hibar D.P. və b. Uşaqlarda və böyüklərdə diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusu olan iştirakçılarda subkortikal beyin həcmi fərqləri: kəsişmə meqa-analizi. «Lancet Psixiatriyası» (Lancet Psychiatry). 2017;4(4):310–319.
14. Volrayç M., Uilson D., Vayt C. Şəkərin uşaqlarda davranışa və ya idraka təsiri: meta-analiz. «JAMA». 1995;274(20):1617–1621.
15. Vaylens T.E., Faraone S.V., Biderman C., Qunawardene S. Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun stimulyator terapiyası sonradan maddə asılılığına səbəb olurmu? Meta-analitik icmal. «Pediatriya» (Pediatrics). 2003;111(1):179–185.
16. Svanson C.M., Arnold L.E., Molina B.S.Q. və b. Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusunun multimodal müalicə tədqiqatının izlənməsində gənc yetkinlik nəticələri: simptomların davamlılığı, mənbələr arasında uyğunsuzluq və boy artımının basdırılması. «Uşaq Psixologiyası və Psixiatriyası Jurnalı» (J Child Psychol Psychiatry). 2017;58(6):663–678.
17. Holtmann M., Sonuqa-Bark E., Kortese S., Brandays D. DİP üçün neyrofiidbek: mövcud sübutların icmalı. «Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası üzrə Şimali Amerika Klinikaları» (Child Adolesc Psychiatr Clin N Am). 2014;23(4):789–806.
18. Kortese S., Ferrin M., Brandays D. və b. Diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntusu üçün neyrofiidbek: randomizə edilmiş nəzarət edilən sınaqların klinik və neyropsixoloji nəticələrinin meta-analizi. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2016;55(6):444–455.
19. Sonuqa-Bark E.C., Brandays D., Kortese S. və b. DİP üçün qeyri-farmakoloji müdaxilələr: pəhriz və psixoloji müalicə üsullarının randomizə edilmiş nəzarət edilən sınaqlarının sistematik icmalı və meta-analizləri. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2013;170(3):275–289.
20. Blox M.H., Kavasmi A. Diqqət çatışmazlığı/hiperaktivlik pozuntusu simptomatologiyası olan uşaqların müalicəsi üçün omeqa-3 yağ turşusu əlavəsi: sistematik icmal və meta-analiz. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2011;50(10):991–1000.
21. Safren S.A., Sprich S., Mimiaga M.C. və b. Dərman müalicəsi alan və qalıcı simptomları olan böyüklərdə koqnitiv-davranış terapiyasına qarşı təhsil

dəstəyi ilə relaksasiya: randomizə olunmuş nəzarətli sınaq. «JAMA». 2010;304(8):875–880.

22. Barkli R.A. Davranışın inhibisiyası, davamlı diqqət və icraedici funksiyalar: DÇHP-nin vahid nəzəriyyəsinin qurulması. «Psixoloji Bülleten» (Psychol Bull). 1997;121(1):65–94.
23. Eyberq S.M., Fanderburk B. Valideyn-uşaq qarşılıqlı təsiri terapiyası protokolu. Geynsvill: PCIT International; 2011.
24. Vebster-Stratton Ç. İnanılmaz illər: valideynlər, müəllimlər və uşaqlar üçün təlim seriyası. Sietl: Incredible Years; 2011.
25. Kessler R.C., Berqlund P., Demler O. və b. Milli Komorbidlik Tədqiqatının Təkrarında DSM-IV pozuntularının ömürlük yayılması və başlanğıc yaşı üzrə paylanmaları. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(6):593–602.
26. Sanders M.R. Triple P-Müsbət Valideynlik Proqramının hazırlanması, qiymətləndirilməsi və çoxmillətli yayılması. «Klinik Psixologiya üzrə İllik İcmal» (Annu Rev Clin Psychol). 2012;8:345–379.

XBT-11 **6A06**	**6A06 STEREOTİPİK HƏRƏKƏT POZUNTUSU** **Stereotyped movement disorder**
XBT-10 F98.4	Stereotip hərəkət pozuntuları
DSM-5-TR F98.4	Stereotipik hərəkət pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Stereotipik hərəkət pozuntusu (XBT-11: 6A06 Stereotyped Movement Disorder; DSM-5-TR: 307.3 Stereotipik hərəkət pozuntusu (F98.4)) — könüllü görünən, təkrarlanan, ritmik, məqsədsiz motor davranışla xarakterizə olunan, gündəlik fəaliyyətə müdaxilə edən və ya bədəni zədələyən neyroinkişaf pozuntusudur. Tipik nümunələr: əllərin yelləməsi (əl çırpma), bədənin yırğalanması (ing. body rocking), baş vurma (ing. head banging), saç çəkmə, dodaq dişləmə, barmaqlarla oynama.

Pozuntu iki formaya görə təsnif edilir:

- İlkin (primary, idiopatik) — başqa neyroinkişaf və ya somatik pozuntu olmadan, normal intellekt əmsalı (IQ) olan uşaqda;

- İkincili — intellektual əlillik, autizm spektri pozuntusu, sensor məhrumiyyət (görmə və ya eşitmə pozuntusu) və ya tibbi vəziyyət fonunda.

DSM-5-TR-də özünə zərərlə və ya özünə zərər olmadan kvalifikatoru müəyyən edilmişdir.

2. Tarixçə

- Kanner L. (1943) — autizmin təsvirində stereotipik davranışları məhdud-təkrarlanan davranış kateqoriyası kimi qeyd etmişdir.
- 1960–1970-ci illər — intellektual əlilliyə dair qapalı müəssisələrdə yaşayan əhali qruplarında stereotipiya təsvir edilmişdir.
- DSM-III-R (1987) — «Stereotipiya/vərdiş pozuntusu» (ing. Stereotypy/Habit Disorder) ayrı kateqoriya kimi müəyyən edilmişdir.
- Mahone E.M. və b. J Child Neurol 2004, 2014 — sağlam koqnitiv inkişafa malik uşaqlarda «ilkin kompleks motor stereotipiyalar» (ing. primary complex motor stereotypies) sindromunu sistematik təsvir etmişlər; bu işdən əvvəl belə uşaqlar adətən autizm spektri pozuntusu kimi yanlış diaqnoz qoyulurdu.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — neyroinkişaf pozuntuları kateqoriyasına daxil edilib; özünə zərər kvalifikatoru əlavə edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Müvəqqəti stereotipiyalar sağlam uşaqların 3–15%-ində 3 yaşa qədər müşahidə olunur (Foster L.G. J Dev Behav Pediatr 1998).
- İlkin (primary) klinik stereotipik hərəkət pozuntusu normal koqnitiv inkişaflı uşaqlarda müşahidə olunur təxminən 3–4% (Freeman R.D. və b. Mov Disord 2010).
- İkincili formalar — intellektual əlillikdə 60%-ə qədər; ağır və dərin intellektual əlillikdə təxminən 80% pasiyentdə hansısa formada stereotipiya; autizm spektri pozuntusunda demək olar ki, həmişə bir formada mövcuddur (Bodfish J.W. və b. J Autism Dev Disord 2000).
- Cins: ilkin formalarda oğlanlarda 3:1; ikincili formalarda fərq daha az.
- Başlanğıc yaşı: tipik 3 yaşa qədər (DSM-5-TR meyarı).
- Özünə zərər vurma (ing. self-injurious behavior; SIB, ÖZV): ümumi əhalidə nadir, lakin ağır intellektual əlillikdə 25–30%, Lesch-Nyhan və ya Cornelia de Lange kimi sindromlarda demək olar həmişə.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Neyrobioloji mexanizmlər

- Bazal qanqliyalar və korteks-striatum dövrəsinin disfunksiyası müəyyən edilir — vərdiş seçimi (ing. habit selection) və motor inhibisiya proseslərinin pozulması (Singer H.S. Semin Pediatr Neurol 2009).
- Dopaminergik sistem — D1 və D2 reseptorlarının disbalansı; eksperimental modellərdə dopamin agonistləri stereotipik davranışı gücləndirir.
- Serotoninergik sistem — bəzi pasiyentlərdə SSGİ (seçici serotonin geri alım inhibitorları) qismən cavab verir.
- Opioid sistem — özünə zərər formalarında endogen opioid disregulasiyası hipotezi (naltrekson qismən effekt verir).

4.2 Genetik və ailə amilləri

- İlkin stereotipiyada ailə kümələnməsi qeydə alınır — ailə tarixçəsi 25–30% (Mahone 2014).
- Spesifik genetik sindromlarda stereotipiya geniş yayılmışdır — Rett (MECP2), Lesch-Nyhan (HPRT1), Cornelia de Lange (NIPBL), Smith-Magenis (RAI1), kövrək X sindromu (ing. Fragile X, FMR1), Phelan-McDermid (22q13).

4.3 Mühit və davranış amilləri

- Sensor məhrumiyyət — institusional mühit, kor və ya kar uşaqlarda yüksək tezliklə rast gəlinir.
- Davranış mexanizmləri — özünü stimullaşdırma (sensor stimul axtarışı), avtomatik gücləndirmə (ing. intrinsic reinforcement), kontekstə bağlı funksional əlaqə (qaçınma, diqqət).
- Stress və narahatlıq pozuntuları stereotipiyanın şiddətini gücləndirə bilər.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Tipik motor modellər

- Əllərin çırpılması/yellənməsi (ing. hand flapping) — ən sıx; emosional həyəcan və ya konsentrasiya zamanı.
- Bədənin yırğalanması (ing. body rocking) — oturmuş və ya ayaq üstə.
- Baş vurma — özünə zərər forması; yastığa, divara və ya yerə.
- Bədəni qucaqlama, barmaqlarla oynama, dodaq dişləmə, saç çəkmə.
- Vizual stimullaşdırma — gözlərin önündə əl çevirmə, işığa baxma.

- Özünə zərər vurma (SIB) — baş vurma, dişləmə, çırpma, dəri qaşıma.

5.2 Klinik xüsusiyyətlər

- Müddət — saniyələrdən saatlara; bir epizodda 5–10 dəqiqə tipikdir.
- Tətikləyicilər — həyəcan (xoş və ya stress doğuran), konsentrasiya, məşğuliyyətsizlik (boş vaxt).
- Diqqət ilə dayandırma — pasiyent çağırıldıqda və ya başqa fəaliyyətə yönəldildikdə davranış dayanır (tiklərdən fərqli olaraq qabaqlayıcı hiss yoxdur — premonitory urge).
- Stereotipiyanın funksional rolu — özünü stimullaşdırma, sakitləşdirmə, sensor qıcıqlanmanın idarəsi.

5.3 Komorbidlik

- İntellektual əlillik (ikincili formalarda).
- Autizm spektri pozuntusu (ilkin stereotipiyada komorbidlik 30–50% — Mahone 2014).
- DDHP — ilkin stereotipiyalı uşaqlarda komorbid 20–35%.
- Narahatlıq və obsesif-kompulsiv pozuntuya (OKP) bənzər simptomlar.
- Tikli pozuntular — ayırd etmək çətin ola bilər.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11 konsensus nöqtələri)

A. Təkrarlanan, məqsədsiz, görünüşdə iradi motor davranış (məs. əl yelləmə, bədən yırğalama, baş vurma, özünü dişləmə).

B. Davranış sosial, akademik və ya başqa fəaliyyətlərə müdaxilə edir və ya özünə zərərlə nəticələnir.

C. Başlanğıc erkən inkişaf dövrünə təsadüf edir (adətən 3 yaşa qədər).

D. Davranış maddə (məs. stimulyant) və ya neyroloji vəziyyət (tik pozuntusu, koreatetoz, distoniya, dermatillomaniya, trixotillomaniya) ilə tam izah olunmur; obsesif-kompulsiv pozuntu (OKP), antisosial şəxsiyyət pozuntusu (ASP) və ya başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah edilmir (komorbidlik istisna deyil).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR (F98.4): şiddət kvalifikatoru — özünə zərərlə və ya özünə zərər olmadan; əlavə kvalifikatorlar — məlum tibbi və ya genetik vəziyyətlə; intellektual əlillik və ya autizm fonunda.

- XBT-11 (6A06): paralel struktur; «məqsədli olmayan təkrarlanan motor davranış» vurğusu.
- Mahone E.M. və b. J Child Neurol 2014: «ilkin kompleks motor stereotipiyalar» (ing. Primary Complex Motor Stereotypies, PCMS) — normal koqnitiv inkişaflı uşaqlarda ayrıca klinik formaya diqqət; tipik əl və qol stereotipiyaları; autizmlə qarışdırılma riski.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Valideyn müsahibəsi və videoyazı ilə sənədləşdirmə (ailənin telefonla qeyd etdiyi epizodlar diaqnostik baxımdan qiymətlidir).
2. İnkişaf və neyroloji müayinə.
3. Tiklər və başqa hərəkət pozuntuları (xorea, mioklonus, distoniya) ilə differensial diaqnostika — neyroloq konsultasiyası.
4. Komorbidlik skrininq — autizm spektri (M-CHAT-R/F, ADOS-2), intellektual əlillik (Vineland-3, intellekt əmsalı — IQ), DDHP, narahatlıq.
5. Sensor pozuntuların istisna edilməsi — eşitmə və görmə testi.
6. Özünə zərər varsa — funksional davranış qiymətləndirməsi (FBA).
7. Spesifik klinik şübhə əsasında — genetik müayinə (xromosomal mikroarray analizi — CMA; FMR1; MECP2; Lesch-Nyhan sindromunda HPRT aktivliyi və sidik turşusu).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Tikli pozuntular (8A05)	Qısa, qeyri-ritmik; qabaqlayıcı hiss (ing. premonitory urge) olur; qısa müddətə saxlanıla bilər, lakin fərqləndirici əlamət dərinin altında «qaşınma» hissidir.
Autizm spektri (6A02)	Stereotipiya komorbid ola bilər; sosial-kommunikativ çatışmazlıq əsasdır.
OKP — kompulsiyalar (6B20)	Eqo-distonikdir; obsessiyalara cavab verir; mənalıdır (təmizlik, simmetriya).
Mioklonus, koreatetoz	Davam etməyən, qeyri-ritmik, qeyri-iradi; neyroloji müayinədə fokus əlamətlər.

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Trixotillomaniya (6B25.0), dermatillomaniya (6B25.1)	Saç çəkmə və dəri qaşıma — bədənə yönəlmiş təkrarlanan davranışlar kateqoriyasında; ümumi stereotipiyadan ayrı.
Tutma (epileptik)	Şüur dəyişikliyi və ya postiktal vəziyyət; EEQ müayinəsi.
Stimulyant induksiyalı stereotipiya	Yüksək dozada amfetamin və ya kokain ilə əlaqəlidir; toksikoloji skrininq.
Müvəqqəti uşaqlıq stereotipiyaları (sağlam)	Funksional pozulma yoxdur; 3 yaşa qədər aradan qalxır; klinik diaqnoz tələb etmir.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik müsahibə və şkalalar

- Stereotypy Severity Scale (SSS) — Miller J.M., Singer H.S. və b.
- Repetitive Behavior Scale-Revised (RBS-R) — autizm və intellektual əlilliklə komorbid hallarda.
- Video qeydləri — ailənin evdə apardığı epizod qeydləri klinikçi tərəfindən qiymətləndirilir.
- Funksional davranış analizi (FBA) — özünə zərər və ya kontekstə bağlı stereotipiyada müdaxilə planlaşdırması üçün.

7.2 Laborator müayinələr

Rutin göstəriş yoxdur. Klinik şübhə əsasında:

- Genetik panel (xromosomal mikroarray analizi — CMA; kövrək X sindromu) — intellektual əlillik və ya sindromal əlamətlər varsa.
- MECP2 analizi (Rett sindromu olan qızlarda).
- HPRT aktivliyi və sidik turşusu — Lesch-Nyhan sindromu şübhəsi (özünə dişləmə).
- Tiroid funksiyası və qurğuşun səviyyəsi müayinə edilir.
- Toksikoloji skrininq — yeniyetmələrdə.

7.3 İnstrumental müayinələr

- Elektroensefaloqrafiya (EEQ) — tutma şübhəsi olduqda.
- Beyin MRT — fokus neyroloji əlamətlər və ya reqressiya.
- Eşitmə və görmə testi — sensor məhrumiyyət rolunu qiymətləndirmək üçün.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər

1. Davranış müdaxiləsi birinci sıra müalicədir — funksional davranış analizi əsasında fərdiləşdirilmiş plan.
2. İlkin (primary) stereotipiya halında — pasiyent funksional çətinlik həyatırsa, müşahidə kifayət ola bilər (Mahone 2014). Ailəyə təbiət və proqnozun izah edilməsi; məcburi müdaxilə tələb edilmir.
3. Funksional çətinlik və ya sosial fəaliyyətə müdaxilə olduqda — Vərdiş əvəzləmə təlimi (HRT — ing. Habit Reversal Training), digər davranışın differensial gücləndirilməsi (DRO), reaksiyanın kəsilməsi və yönləndirilməsi (RIRD) sübutlu davranış müdaxilələridir.
4. Özünə zərər vurmada — multidissiplinar yanaşma; davranış müdaxiləsi + qoruyucu cihazlar (yastıq başlıq) + farmakoterapiya (refrakter hallarda).
5. Sensor məhrumiyyət — mühitin zənginləşdirilməsi (oyuncaq, sosial qarşılıqlı təsir), pasiyentə sensor stimul təmin edən alternativ fəaliyyətlər.
6. Komorbidlik müalicəsi — autizm, intellektual əlillik, DDHP, narahatlıq.
7. Farmakoterapiya məhdud sübut bazasına malikdir — yalnız ağır, davranış müdaxiləsinə cavab verməyən hallarda; özünə zərər və ya autizm və intellektual əlilliklə komorbidlik kontekstində tətbiq edilir.

8.2 Farmakoterapiya (məhdud sübut)

- Atipik antipsixotik (risperidon, aripiprazol) — autizm/intellektual əlillik fonunda davranış aqressiyası və özünə zərər üçün; ABŞ Qida və Dərman Administrasiyasının (FDA) təsdiqi — risperidon 5–16 yaşlı uşaqlarda autizm spektri pozuntusuna bağlı irritabellik üçün (özünə zərər daxil), aripiprazol 6–17 yaş ASP irritabellik üçün. Stereotipik hərəkət pozuntusunun «nüvə» simptomları üçün FDA təsdiqli preparat yoxdur.
- SSGİ — fluoksetin, sertralin — bəzi pasiyentlərdə zəif effekt verir, xüsusilə narahatlıqla komorbid hallarda; sübut bazası məhduddur.
- Naltrekson — özünə zərər vurmada nəzərdə tutulur (endogen opioid hipotezi əsasında); RKİ sübutu məhduddur, Symons F.J. və b. Am J Ment Retard 2004 icmal — kiçik effekt ölçüsü.

- Klonidin, quanfasin — komorbid DDHP və ya yuxu pozuntusunda kömək edə bilər.

8.3 Xüsusi vəziyyətlər

- Özünə zərər (SIB): təcili davranış analizi; qoruyucu vasitələr (dəbilqə, qolu məhdudlaşdıran vasitə) qısamüddətli; davranış intensiv müdaxiləsi; farmakoterapiya refrakter hallarda; ağır hallarda stasionar müalicə.
- Spesifik genetik sindromlar — Lesch-Nyhan sindromunda özünə dişləmə demək olar ki, həmişə müşahidə olunur; ağız və diş sağlamlığı üzrə güzəştli yanaşma (dişlərin çıxarılması son seçimdir); allopurinol metabolik pozuntunun korreksiyası üçün tətbiq edilir.
- Sensor məhrumiyyət — mühit dəyişikliyi, alternativ sensor input.

8.4 Müalicə metodikaları

1. Vərdiş Əvəzləmə Təlimi (ing. Habit Reversal Training, HRT) — Azrin (Azrin N.H.), Nann (Nunn R.G.) — Beş əsas komponent — davranışın tanınması (ing. awareness training), rəqib davranışın öyrədilməsi (ing. competing response training), motivasiya komponenti, sosial dəstək, ümumiləşdirmə təlimi (ing. generalization training). Stereotipik hərəkət pozuntusunda və tik pozuntularında sübutlu. Sübut: Specht M.W. və b. J Child Neurol 2017 RKİ — ilkin kompleks motor stereotipiyada şiddət azalması.
2. Digər Davranışın Differensial Gücləndirilməsi (ing. Differential Reinforcement of Other behavior, DRO) — Stereotipiya olmadan keçən vaxt intervallarının müsbət gücləndirilməsi (nişan, tərifləmə, fəaliyyət). İntellektual əlillik fonunda effektivdir. Tətbiqi davranış analizinin (ABA) əsas komponentlərindən biridir.
3. Reaksiyanın Kəsilməsi və Yönləndirilməsi (ing. Response Interruption and Redirection, RIRD) — Stereotipiya başladıqda fasilə və alternativ məşğuliyyət tapşırığına yönləndirmə. Vokal stereotipiyalarda və ağır hallarda istifadə olunur. Ahearn W.H. və b. J Appl Behav Anal 2007.
4. Funksional Davranış Qiymətləndirməsi (FDQ — funksional davranış qiymətləndirməsi; ing. Functional Behavior Assessment — FBA) — Davranışın öncül stimulu (antecedent), funksional nəticəsi və kontekstinin sistematik analizi — müdaxilə planının fərdiləşdirilməsinin əsası. ABA və PBS daxilində.
5. Stereotipiya Şiddət Şkalası (ing. Stereotypy Severity Scale, SSS) — Miller (Miller J.M.), Singer (Singer H.S.) — Stereotipiyanın tezliyi, müddəti, intensivliyi və müdaxiləyə ehtiyac dərəcəsi standart şəkildə qiymətləndirilir.

6. Təkrarlanan Davranış Şkalası-Yenilənmiş (ing. Repetitive Behavior Scale-Revised, RBS-R) — Bodfiş (Bodfish J.W.) və b. — 43 maddəlik valideyn sorğusu — stereotipiya, özünə zərər, kompulsiv davranış, ritüallaşdırma, eyniliyə tələb, məhdud davranış altşkalaları. Autizm və intellektual əlillik komorbid hallarda istifadə.

8.5 Mənbələr arasında fərqlər

- Mahone E.M. və b. J Child Neurol 2014: ilkin formalarda məcburi müdaxilə tələb edilmir; ailəyə proqnoz və təbiət izahı; HRT yeniyetməlikdə effektiv.
- AAP — özünə zərər vurma protokolu: Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) — özünə zərər vurma protokolu: intellektual əlilliyi olan uşaqlarda multimodal yanaşma.
- NICE NG11 («Davranış çətinlikləri və öyrənmə əlilikləri», 2015): intellektual əlillikdə davranış müdaxiləsi birinci sıra; antipsixotik yalnız refrakter hallarda və qısamüddətli.

9. Proqnoz

Əlverişli proqnoz amilləri

- İlkin forma zamanı intellekt əmsalı (IQ) normaldır.
- Özünə zərər olmaması.
- Erkən HRT müdaxilə cavabı.
- Komorbidlik olmaması.
- Ailənin dəstəyi və realist gözləntilər də əlverişli amillər sırasındadır.

Əlverişsiz proqnoz amilləri

- İkincili form — ağır intellektual əlillik və ya genetik sindrom kontekstində.
- Özünə zərər vurma — xüsusilə Leş-Nihan və Korneliya de Lanqe sindromları.
- Komorbid autizm spektri pozuntusunun (ASP) olması əlverişsiz proqnoz amilidir.
- Davranış müdaxiləsinə cavabın olmaması əlverişsiz proqnoz amilidir.

İzləmə hədəfləri

- Stereotipiyaların tezliyi, müddəti və intensivliyi (SSS) hər 3–6 ayda bir qiymətləndirilməlidir.
- Funksional pozulma və özünə zərər verən davranış monitorinq edilməlidir.

- Komorbid pozuntuların (autizm spektri pozuntusu, DDHP, narahatlıq, OKP) skrininqi aparılmalıdır.
- Yeniyetməlik və yetkinlikdə sosial uyğunlaşma dəstəyi.
- Farmakoterapiya alan pasiyentlərdə yan təsirlərin (metabolik, EKPS) izlənməsi aparılmalıdır.

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «Stereotipiya həmişə autizmin əlamətidir»

Niyə yayılmışdır: stereotipiyaların autizmin DSM-5 meyarlarına daxil olması və kütləvi informasiya vasitələrində birinci növbədə autizmlə əlaqələndirilməsi.

Klinik və bioloji məntiq: Mahone E.M. və b. J Child Neurol 2004, 2014 — «İlkin mürəkkəb motor stereotipiyaları» sindromu normal koqnitiv inkişaflı uşaqlarda sosial qarşılıqlı əlaqə çatışmazlıq və ya məhdud-təkrarlanan davranış paterni olmadan da baş verə bilər. Bu uşaqların 30–50%-ində komorbid autizm spektri pozuntusu və ya DDHP ola bilər, əksəriyyətində isə müşahidə olunmur.

Sübut: Mahone 2014; Freeman R.D. və b. Mov Disord 2010 — ilkin stereotipiya autizmdən fərqli klinik vahiddir.

Real klinik addım: hər stereotipik davranışlı uşaq üçün autizm spektri ayrı differensial olaraq qiymətləndirilməlidir; komorbid olmasa, ailə qorxudulmamalıdır.

Mif 2: «Stereotipiya pis tərbiyə və ya emosional məhrumiyyətin nəticəsidir»

Niyə yayılıb: 1960-cı illərdə internat müəssisələrində saxlanılan uşaqlarda yüksək yayılma göstəriciləri «məhrumiyyət» nəzəriyyəsini gücləndirdi.

Sübut: Bodfish J.W. və b. J Autism Dev Disord 2000 — stereotipiya neyrobioloji əsaslı pozuntudur, bazal qanqlionların və kortiko-striatal dövrənin disfunksiyası ilə əlaqədardır. Sensor məhrumiyyət şiddətinə təsir göstərə bilər, lakin onun etiologiyası deyildir. Sağlam ailə mühitində böyüyən, dəstəkləyici ailəsi olan uşaqlarda da müşahidə olunur.

Mif 3: «Uşaq yaşa görə keçəcək — heç bir müalicə tələb olunmur»

Sübut: Müvəqqəti uşaqlıq stereotipiyaları 3 yaşa qədər azala bilər; lakin ilkin stereotipiyalar davam edir; lakin ilkin klinik stereotipiya tipik olaraq davam edir — Mahone 2014 izləmə tədqiqatları yetkinliyə qədər sənədləşmişdir. Ailəyə real

proqnoz izah edilməlidir; özünə zərər və ya funksional pozulma varsa müdaxilə tələb olunur.

10.2 Zərərli və ya yanlış üsullar

Mif 4: «Uşağı fiziki məhdudlaşdırmaq (qolların fiksasiyası, hərəkətin məhdudlaşdırılması) stereotipiyanı keçirər»

Niyə yayılmışdır: intuitiv olaraq davranışın «saxlanması» simptomu aradan qaldırır kimi görünür.

Klinik məntiq və sübut: davamlı fiziki məhdudlaşdırma kontrproduktivdir — pasiyentin distresini artırır, autonomiyasını pozur, dəri zədəsi və kontrakturalar yaradır. NICE NG11 (2015), Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) — məhdudlaşdırma yalnız təcili və qısamüddətli özünə zərər vəziyyətlərində qoruyucu məqsədlə; davamlı müalicə kimi tövsiyə edilmir. Funksional davranış analizi əsaslı müsbət davranış dəstəyi (ing. PBS — positive behavior support) üstün.

Mif 5: «Cəza (kəskin yenidən istiqamətləndirmə, danlama, fiziki cəza) stereotipiyanı keçirər»

Sübut: NICE NG11 — cəza əsaslı yanaşma davranışın azaldılmasında effektiv deyil; emosional zərər və travma riski yaradır. tətbiqi davranış analizi (ABA) praktikası da müasir formada cəza əvəzinə müsbət gücləndirməyə (diferensial gücləndirmə — DRO) əsaslanır.

Mif 6: «Antipsixotiklər bütün stereotipik hərəkətlərə effektivdir»

Sübut: antipsixotiklər (risperidon, aripiprazol) FDA təsdiqi autizm spektri pozuntusu (ASP) ilə bağlı irritabillik üçün — özünə zərər daxil. İlkin stereotipiya üçün FDA təsdiqi yoxdur; əsas stereotipiya simptomlarına təsiri məhduddur. Yan təsir yükü (metabolik, EKPS, prolaktin) əhəmiyyətlidir. NICE NG11 — antipsixotik yalnız refrakter ağır davranış üçün və qısamüddətli.

10.3 Səmərəsiz və ya elmi cəhətdən əsassız üsullar

Mif 7: «Sensor inteqrasiya terapiyası (Ayres SI) stereotipiyanı aradan qaldırır»

Sübut: AAP-ın 2012-ci il sensor inteqrasiya bəyanatı — terapevtik təsiri «tədqiqatı davam edən» kimi təsnif edilir; stereotipik davranış üçün spesifik effekt sübutu zəifdir. Funksional davranış müdaxiləsi (HRT, DRO) sübut baxımından üstündür.

Mif 8: «Hiperbarik oksigen kamerası, kök hüceyrə inyeksiyaları, xelatlaşdırma terapiyası stereotipiyanı aradan qaldırar»

Sübut: Cochrane və FDA xəbərdarlıqları (autizm fonunda da eyni mövqe) — bu müdaxilələrin stereotipiya və ya neyroinkişaf pozuntusu üçün effekti yoxdur, risk profili əhəmiyyətlidir.

Mif 9: «Xüsusi pəhriz (qlutensiz, kazeinsiz) stereotipiyanı keçirər»

Sübut: Hyman S.L. və b. AAP 2020 — stereotipiya və ya autizm üçün xüsusi pəhrizin effekti sübut edilməyib.

Mif 10: «EEQ neyrobiyoloji əks-əlaqə stereotipiyanı aradan qaldırar»

Sübut: spesifik stereotipik hərəkət pozuntusu üçün neyrofidbek sübut bazası yoxdur. DDHP-də yüngül effekt, lakin stereotipik davranışa ekstrapolyasiya əsassızdır.

Mif 11: «Homeopatiya, akupunktura, kraniosakral terapiya»

Sübut: heç birinin stereotipik hərəkət pozuntusu üçün effekti sübut edilməyib.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və Xəstələnmə Statistikası üzrə XBT-11. 6A06 Stereotipli hərəkət pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. Vaşinqton: APA Publishing; 2022.
3. Mahone E.M., Bridges D., Prahme C., Singer H.S. Uşaqlarda təkrarlanan qol və əl hərəkətləri (kompleks motor stereotipləri). «Uşaq Nevrologiyası Jurnalı» (J Child Neurol). 2004;19(5):379–383.
4. Singer H.S. Motor stereotipləri. «Seminars in Pediatric Neurology» (Semin Pediatr Neurol). 2009;16(2):77–81.
5. Friman R.D., Soltanifar A., Baer S. Stereotipik hərəkət pozuntusu: asanlıqla gözdən qaçırılan. «İnkişaf Təbabəti və Uşaq Nevrologiyası» (Dev Med Child Neurol). 2010;52(8):733–738.
6. Bodfiş C.V., Simons F.C., Parker D.E., Levis M.H. Autizmdə təkrarlanan davranışın növləri: əqli geriliyə nisbətdə müqayisələr. «Autizm və İnkişaf Pozuntuları Jurnalı» (J Autism Dev Disord). 2000;30(3):237–243.
7. Spekt M.V., Mahone E.M., Klayn T. və b. Birincili kompleks motor stereotipləri üçün valideyn tərəfindən həyata keçirilən davranış terapiyasının effektivliyi. «Uşaq Nevrologiyası Jurnalı» (J Child Neurol). 2017;32(2):204–212.

8. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) Təlimatı NG11. Çətin davranış və öyrənmə əlilliklər: davranışı çətin olan öyrənmə əlilliyi olan şəxslər üçün profilaktika və müdaxilələr. 2015.
9. Simons F.C., Tompson A., Rodriqez M.C. Özünə zərər verən davranış və naltrekson müalicəsinin effektivliyi: kəmiyyət sintezi. «Əqli Gerilik və İnkişaf Əlilliklər üzrə Tədqiqat İcmaları» (Ment Retard Dev Disabil Res Rev). 2004;10(3):193–200.
10. Ahern V.H., Klark K.M., MakDonald R.P., Çunq B.İ. Autizmli uşaqlarda vokal stereotipiyanın qiymətləndirilməsi və müalicəsi. «Tətbiqi Davranış Analizi Jurnalı» (J Appl Behav Anal). 2007;40(2):263–275.
11. Foster L.C. Məktəbəqədər uşaqlarda əsəbi vərdişlər və stereotipli davranışlar. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 1998;37(7):711–717.
12. Hayman S.L., Levi S.E., Mayers S.M.; Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) Əlilliyi olan Uşaqlar üzrə Şurası. Autizm Spektri Pozuntusu olan uşaqların müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə olunması. «Pediatriya» (Pediatrics). 2020;145(1):e20193447.
13. Azrin N.H., Nann R.C. Vərdişin dəyişdirilməsi: əsəbi vərdişlərin və tiklerin aradan qaldırılması üsulu. «Davranış Tədqiqatı və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1973;11(4):619–628.
14. Miller C.M., Singer H.S., Bridges D.D., Varanç H.R. Autizm olmayan uşaqlarda stereotipik hərəkətlərin müalicəsi üçün davranış terapiyası. «Uşaq Nevrologiyası Jurnalı» (J Child Neurol). 2006;21(2):119–125.

XBT-11 **8A05.0**	**8A05.0 İLKİN TİKLƏR VƏ YA TİK POZUNTULARI** **Primary tics or tic disorders**
XBT-10 F95.2	Turret sindromu
DSM-5-TR F95.2	Turret sindromu (digər tik pozuntuları F95.0–F95.1)

1. Tərif və nozologiya

İlkin tiklər və ya tik pozuntuları (XBT-11: 8A05.0 İlkin tiklər və ya tik pozuntuları; DSM-5-TR: 307.23; XBT-10: F95.0–F95.2) — qəfil, sürətli, təkrarlanan, qeyri-

ritmik, qeyri-iradi və ya yarımiradi motor hərəkətlər və ya vokal səs çıxarmaları ilə xarakterizə olunan neyroinkişaf pozuntuları qrupudur. Tiklər tipik olaraq qabaqlayıcı hiss (premonitor urge — qıcıq və ya gərginlik) ilə müşayiət olunur və qısa müddətə iradi olaraq saxlanıla bilər.

XBT-11 və DSM-5-TR-də üç əsas kateqoriya:

- Turret sindromu (DSM-5-TR 307.23) — çoxsaylı motor tikləri və bir və ya bir neçə vokal tik ən azı 1 il davam etmişdir; başlanğıc yaşı 18-dən əvvəldir;
- Davamlı (xronik) motor və ya vokal tikli pozuntu (DSM-5-TR 307.22) — motor və ya vokal tiklər (lakin hər ikisi birlikdə deyil) ən azı 1 il davam etmişdir;
- Müvəqqəti tikli pozuntu (DSM-5-TR 307.21) — tik (motor və ya vokal) 1 ildən az davam etmişdir; başlanğıc yaşı 18-dən əvvəldir.

2. Tarixçə

- Itard J.M.Q. (1825) markiza de Dampierre-də motor və vokal tiklərin ilk klinik təsvirini vermişdir.
- Gilles de la Turret G. (1885) — Salpêtrière xəstəxanasında Charcot-un göstərişi ilə 9 pasiyentin klassik təsviri; sindromun adı.
- 1960-cı illər — psixoanalitik izah dominant olmuşdur («nevrotik pozuntu»).
- 1961 (Seignot J.N.) 1961 (Seignot J.N.) — haloperidolun tiklərə təsiri ilk dəfə klinik olaraq aşkar edilmiş və neyrobioloji konsepsiyaya keçidin əsası qoyulmuşdur. neyrobioloji konsepsiyaya keçidin əsası.
- DSM-III (1980) və sonrakı redaksiyalarda tiklər tibbi pozuntu kimi rəsmi tanınmışdır.
- AAN 2019 (Pringsheim T. və b. Neurology 2019;92(19)) — beynəlxalq sübuta əsaslanan klinik göstəriş; α2-aqonistlərin antipsixotiklərlə müqayisədə daha əlverişli yan təsir profili ilə birinci sıra olduğu vurğulanmışdır.
- ESSTS (Avropa Turret Sindromunun Öyrənilməsi Cəmiyyəti) — Avropa klinik tövsiyələri (2011, 2022-ci il yenilənməsi).

3. Epidemiologiya

- Turret sindromunun yayılması: uşaqlarda 0,5–1% (Knight T. və b. Pediatr Neurol 2012 sistemli icmal).
- Davamlı motor və ya vokal tik: təxminən 1–2%.

- Müvəqqəti tiklər: Müvəqqəti tiklər məktəb yaşlı uşaqların 20%-dən çoxunda müşahidə olunur.
- Cinsə görə: kişilərdə rast gəlmə tezliyi 3–4 dəfə yüksəkdir.
- Başlanğıc yaşı: 5–7 yaş; şiddətin ən yüksək həddi 10–12 yaşa təsadüf edir.
- Davamlılıq: yetkinlikdə tiklər təxminən 50%-də əhəmiyyətli azalır, təxminən 30%-də davam edir; təxminən 20%-də ağır forma qalır (Bloch M.H., Leckman J.F. J Psychosom Res 2009).
- Komorbid pozuntular: Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu (DDHP) 50 –60%, obsesiv-kompulsiv pozuntu (OKP) 30–50%, narahatlıq 30%, depressiya 20%, öyrənmə pozuntusu 20–30% hallarda müşahidə olunur.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

- İrsilik: 0,77 (Mataix-Cols D. və b. JAMA Psychiatry 2015 ailə və əkiz tədqiqatları, n > 200 000 (İsveç)) ən yüksək irsilik göstəricisinə malik psixiatrik pozuntulardan biridir.
- Poligen təbiət: GWAS (Yu D. və b. Am J Psychiatry 2019) — risk lokusları aşkar edilmişdir; tək gen yoxdur.
- Nadir mutasiyalar: SLITRK1, HDC (histidin dekarboksilaza), CELSR3 — az sayda ailədə müəyyən edilmişdir.
- Ailə tarixçəsində OKP və DDHP tezliyi yüksəkdir — genetik üst-üstə düşmə.

4.2 Neyrobioloji mexanizmlər

- Kortiko-striato-talamo-kortikal (CSTC) dövrəsi disfunksiyası — bazal qanqliyalar və bağlı sahələrdə motor inhibisiyanın pozulması (Leckman J.F. və b. Neuron 2000;28(2):349–354).
- Dopaminergik sistemin hiperaktivliyi — dopamin antaqonistlərinin (haloperidol, risperidon) tikləri azaltma mexanizmi.
- Histaminergik sistemdə HDC mutasiyaları nadir hallarda rast gəlinir; bu sistemin tonusu aşağıdır.
- Struktur dəyişikliklər: kaudat həcminin azalması, sensorimotor kortikal nazikləşmə (Sowell E.R. və b. Nat Neurosci 2008).

4.3 Mühit amilləri (modifikator)

- Erkən doğum, perinatal hipoksiya — riski yüngül dərəcədə artırır.
- Ananın hamiləlik dövründə tütün istifadə etməsi riski artırır.

- Psixososial stres — tiklərin başlanğıcına səbəb deyildir, şiddətinə təsir edir.
- PANDAS / PANS (streptokokk infeksiyası ilə əlaqəli pediatrik autoimmun neyropsixiatrik pozuntular — PANDAS / pediatrik kəskin başlanğıclı neyropsixiatrik sindrom — PANS) — nadir; əksər hallar əslində tipik Turret/OKP-dir (bax: genişləndirilmiş §10).

5. Klinik təzahürlər

5.1 Motor tiklər

- Sadə motor tiklər: göz qırpma (ən çox rast gəlinən başlanğıc simptomu), burun çəkmə, baş silkələmə, çiyin atma, dodaq hərəkətləri.
- Mürəkkəb motor tiklər: ardıcıl hərəkətlər — tullanma, toxunma, fırlanma; nadir hallarda ədəbsiz jest (kopropraksiya, təxminən 5%).

5.2 Vokal/səs tiklər

- Sadə vokal: öskürək, burun çəkmə, fısıltı, boğaz təmizləmə, qışqırıq.
- Mürəkkəb vokal: kəlmə, exolaliya (başqasının sözlərinin təkrarı), palilaliya (öz sözünün təkrarı).
- Koprolaliya (ədəbsiz söz və ya ifadə) — Turret sindromu olan kişi pasiyentlərin 19,3%-ində, qadın pasiyentlərin 14,6%-ində rast gəlinir (Freeman R.D. və b. Dev Med Child Neurol 2009 beynəlxalq Turret verilənlər bazası, n = 597), kütləvi informasiya vasitələrindəki obrazdan fərqlidir.

5.3 Premonitor hiss və könüllü saxlama

Pasiyentlərin əksəriyyəti tikdən əvvəl premonitor hissi (qıcıq və ya gərginlik hissi) qeyd edir; tik bu hissi müvəqqəti rahatladır. Tiklər qısa müddətə (saniyələrdən dəqiqələrə qədər) iradi olaraq saxlanıla bilər, lakin bu saxlama daxili gərginlik və narahatlıq yaradır — sonrakı tik epizodu adətən daha intensiv olur.

5.4 Gediş və dəyişkənlik

- Tiklər «dalğavari gediş» — şiddəti dövri olaraq dəyişir; bir tik tipi digəri ilə əvəz olunur.
- Tətikləyicilər — stres (müsbət və ya mənfi), həyəcan, yorğunluq, müəyyən kontekstlər (məs. məktəbdə tiklərin saxlanması).
- Yuxu zamanı tiklər azalır, lakin tamamilə yox olmur.
- Şiddətin ən yüksək həddi 10–12 yaşa təsadüf edir; yeniyetməlik dövründə əksər pasiyentlərdə azalma müşahidə olunur.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11, AAN 2019 konsensus nöqtələri)

Turret sindromu üçün:

1. Çoxsaylı motor tikləri və bir və ya bir neçə vokal tik (müxtəlif vaxtlarda olmuş, hazırda eyni vaxtda olması vacib deyil).
2. Tiklər ən azı 1 il davam etmişdir (zamana görə dəyişə bilər).
3. Başlanğıc 18 yaşa qədər.
4. İstisnalar — maddə (məs. kokain) və ya tibbi vəziyyət (Hantinqton xəstəliyi, postviral ensefalit) ilə tam izah olunmur.

Davamlı motor və ya vokal tikli pozuntu: Turret ilə eyni meyarlar, lakin tək tipli tik (motor və ya vokal, ikisi birdən deyil).

Müvəqqəti tikli pozuntu: Turret ilə eyni meyarlar, lakin müddət < 1 il.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: üç ayrı kateqoriya (F95.0, F95.1, F95.2). «Funksional pozulma» və «şiddət» diaqnostik tələblərə daxil edilməyib — sadəcə meyarların qarşılanması diaqnostik olaraq kifayətdir; lakin müdaxilə qərarı funksional pozulmaya əsaslanır.
- XBT-11 (8A05.0): «ilkin tiklər və ya tik pozuntuları» — alt-spesifikasiyalar Turret, davamlı, müvəqqəti.
- AAN 2019 (Pringsheim T. və b.): diaqnoz klinikdir, video qeydləri yardımçıdır; Yale Qlobal Tik Şiddət Şkalası (YGTSS) ilkin göstəricilər və izləmə üçün; komorbidlik (DDHP, OKP) mütləq qiymətləndirilməlidir.
- ESSTS 2022 (Müller-Vahl K.R. və b.): Avropa kontekstində — eyni meyarlar; CBIT-i birinci sıra qeyri-farmakoloji müdaxilə kimi qəbul edir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Valideyn və pasiyentlə müsahibə aparılır: başlanğıc yaşı, gedişi, tətikləyiciləri və qabaqlayıcı hiss müəyyən edilir.
2. Video qeydləri — ailə tərəfindən evdə çəkilmiş epizodlar (klinika kontekstində tiklər tez-tez azalır).
3. Standartlaşdırılmış şkala — Yale Qlobal Tik Şiddət Şkalası (YGTSS) ilkin göstəricilər və monitorinq üçün tətbiq edilir.
4. Komorbidlik skrininq — DDHP (Konners, Vanderbilt şkalaları), OKP (CY-BOCS), narahatlıq, depressiya, öyrənmə pozuntusu, yuxu.

5. Neyroloji müayinə — fokal nevroloji əlamətlər, xoreoatetoz istisnası.
6. Spesifik klinik şübhədə — Hantinqton xəstəliyi (HTT geni), Wilson xəstəliyi (seruloplazmin, mis), neyroakantositoz.
7. PANDAS/PANS şübhəsi — yalnız klassik klinik tablo (sürətli başlanğıc, OKP + tiklər + emosional labilik, poststreptokokk dövr) varsa; rutin antistreptolizin O testləri tövsiyə edilmir (NIMH 2017).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Stereotipik hərəkət pozuntusu (6A06)	Ritmik, daha uzunmüddətli (saniyələr–dəqiqələr), premonitor hiss yoxdur; başlanğıc < 3 yaş.
Mioklonus	Qısa, ani, könüllü olmayan, premonitor hiss yoxdur; neyroloji etiologiya.
Koreatetoz, distoniya	Davamlı qeyri-iradi hərəkətlər; saxlama mümkün deyil; neyroloji müayinə.
OKP (6B20) — kompulsiyalar	Eqo-distonik məqsədli ardıcıllıqlar; obsessiyaya cavab. Komorbidlik tez-tez rast gəlinir.
Funksional tik (funksional tikəbənzər davranış)	Yetkinlik dövründə qəfil başlanğıc, kompleks qəribə nümunələr, kütləvi mediadan köçürmə; COVID-19 dövründə artım müşahidə olunmuşdur (Pringsheim T. və b. Mov Disord Clin Pract 2021).
PANDAS/PANS	Sürətli başlanğıc post-streptokokk; OKP + tik birgə partlayışı; nadir.
Tutma (epileptik)	Şüur dəyişikliyi; EEQ.
Wilson xəstəliyi	Hepatik və neyroloji simptomlar; Kayser-Fleischer üzüyü, seruloplazminin azalması.
Huntington xəstəliyi	Tipik yetkinlikdə başlanğıc; xoreya, koqnitiv enmə, ailə tarixçəsi.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik şkalalar

- YGTSS (ing. Yale Global Tic Severity Scale, Leckman J.F. və b. 1989) — motor və vokal tiklər üçün ayrı-ayrılıqda; tezlik, intensivlik, mürəkkəblik, maneə olma dərəcəsi və say göstəriciləri hər biri 0–5 bal ilə qiymətləndirilir; global pozulma 0–50. Şkala ilkin göstəricilər və müalicənin monitorinqi üçün istifadə edilir.
- Tiklər üçün qabaqlayıcı istək şkalası (PUTS).
- CY-BOCS — komorbid OKP qiymətləndirməsi.
- Konners-3 və Vanderbilt şkalaları komorbid DDHP-nin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir.

7.2 Laborator müayinələr

Rutin tiklərdə spesifik laborator göstəriş yoxdur. Klinik şübhə əsasında:

- Tiroid funksiyası (TSH) hipertireoz zamanı yoxlanılır.
- Seruloplazmin, 24 saatlıq sidikdə mis — Wilson xəstəliyi şübhəsi (xüsusilə hepatik və ya kinezitik əlamətlər əlavə olunduqda).
- HTT — Hantinqton xəstəliyi şübhəsi (ailə tarixçəsi).
- Streptokokk antikoru (ASO, anti-DNaz B) — yalnız klassik PANDAS klinik tablosu varsa; rutin tövsiyə edilmir.

7.3 İnstrumental müayinələr

- Elektroensefaloqrafiya (EEQ) yalnız tutma şübhəsi olduqda aparılır.
- Beyin maqnit-rezonans tomoqrafiyası (MRT) fokal nevroloji əlamətlər olduqda aparılır, atipik klinik tablo.
- Tiklər üçün rutin neyrovizualizasiya tövsiyə edilmir.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (AAN 2019, ESSTS 2022 konsensusu)

1. Müdaxilə qərarı funksional pozulmaya əsaslanır — yüngül tiklər müşahidə edilə bilər; aqressiv müdaxilə tələb edilmir.
2. Ailəyə və məktəbə psixoedukasiya birinci addım — tiklərin təbiəti, «dalğavari gediş» və qabaqlayıcı hiss izah edilir.

3. Davranış müdaxiləsi — CBIT — Tiklər üçün kompleks davranış müdaxiləsi AAN 2019-a görə 8 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün birinci sıra tövsiyə edilir. HRT (ing. Habit Reversal Training) + funksional müdaxilə + relaksasiya.
4. Farmakoterapiya — funksional pozulma olduqda və CBIT mövcud deyilsə və ya kifayət qədər effekt vermədikdə:
    - Birinci sıra: α2-adrenergik aqonistlər — klonidin, quanfasin (uzadılmış buraxılış — ER) — yan təsir profili antipsixotiklərdən üstündür; xüsusilə komorbid DDHP-də faydalı.
    - İkinci sıra: atipik antipsixotik — aripiprazol (Turret sindromunda 6 –18 yaş üçün FDA təsdiqlidir, 2014), risperidon, ziprasidon. Daha güclü antitik effekt, lakin metabolik və EKPS yan təsirlər.
    - Üçüncü sıra: tipik antipsixotik — haloperidol, pimozid (FDA təsdiqi Turret üçün, lakin EKPS və QTc uzanma riski).
    - Refrakter hallarda — VMAT2 inhibitorları (tetrabenazin təsdiqlənməmiş göstərişlərlə; deutetrabenazin və valbenazin tiklər üçün tədqiqatlar davam etdirilir), botulinum toksini fokal tiklərdə.
5. Komorbid pozuntuların müalicəsi — DDHP (stimulyantlar tikləri əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmir — Bloch M.H. və b. JAACAP 2009 meta-analiz; lakin pasiyentlər izlənilməlidir), OKP (SSGİ + KDT), narahatlıq, yuxu.
6. Refrakter ağır Turret-də — Dərin beyin stimulyasiyası (ing. DBS — deep brain stimulation) — talamusun sentromedian-parafassikulyar nüvəsi və ya GPi (daxili qlobus pallidus) hədəfləri; sertifikatlaşdırılmış mərkəzdə multidissiplinar seçim (Schrock L.E. və b. Mov Disord 2015).

8.2 Farmakoterapiya — birinci sıra (α2-aqonistlər)

Preparat	Forma	Doza diapazonu	Qeyd
Clonidine	IR / TDS (transdermal)	0,05–0,3 mq/gün (bölünmüş və ya TDS)	Sedasiya, hipotenziya; DDHP komorbidliyi olan hallarda faydalıdır.
Quanfasin ER	Uzunmüddətli	1–4 mq/gün (bir dəfə)	Daha az sedasiya, selektiv α2A; DDHP-də FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir.

8.3 İkinci sıra (atipik antipsixotik)

Preparat	Doza diapazonu	Yan təsir profili
Aripiprazol	2–20 mq/gün	Akatiziya, sedasiya; metabolik yan təsirlər daha az ifadə olunur.
Risperidon	0,25–6 mq/gün	Çəki artımı, prolaktin yüksəlməsi, EKPS.
Ziprasidon	20–80 mq/gün	QTc uzanması; EKG monitorinqi tələb olunur.

8.4 Üçüncü sıra (tipik antipsixotik)

- Haloperidol 0,5–4 mq/gün — FDA təsdiqi Turret üçün, lakin EKPS, tardiv diskineziya, sedasiya yan təsirləri.
- Pimozid 1–4 mq/gün — FDA təsdiqi Turret; QTc uzanması riski; EKG monitorinqi mütləqdir.

8.5 Komorbid hallarda yanaşma

- DDHP + tik: α2-aqonist + stimulyant və ya atomoksetin. Stimulyantlar mübahisəli «tikləri gücləndirən amil» olaraq uzun müddət müzakirə edilmişdir, lakin Bloch 2009 meta-analizi və TACT (Tikləri olan uşaqlarda DEHP müalicəsi) tədqiqatı (Turret Sindromunun Tədqiqi Qrupu. Neurology 2002;58(4):527–536) — orta dozada metilfenidat tikləri əhəmiyyətli gücləndirmir; tiklərin şiddəti izlənilməlidir.
- OKP + tik: SSGİ + ERP; aripiprazol və ya risperidon əlavə terapiya kimi.
- Yuxu pozuntusu: melatonin; klonidin yuxu komponentinə də kömək edir.

8.6 Müalicə metodikaları

1. Tiklər üçün Kompleks Davranış Müdaxiləsi (ing. Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, CBIT) — Vuds (Woods D.W.), Piaçentini (Piacentini J.) — Birinci sıra qeyri-farmakoloji müdaxilə (AAN 2019). Üç əsas komponent: (1) Habit Reversal Training (HRT — premonitor hiss tanınması, rəqib davranış öyrənmə); (2) funksional müdaxilə (tikləri gücləndirən kontekstlərin dəyişdirilməsi); (3) relaksasiya təlimi. Standart kurs 10 həftə ərzində 8 fərdi seansdan ibarətdir; sonra təkrar seanslar davam etdirilir. Sübut: Piacentini J. və b. JAMA 2010 randomizə edilmiş nəzarətli sınağı — əsas tədqiqat; Wilhelm S. və b. Arch Gen Psychiatry 2012 yetkinlərdə RKİ; effekt ölçüsü orta. tourette.org.

2. Vərdişin əvəzlənməsi təlimi (HRT) — Azrin (Azrin N.H.), Nann (Nunn R.G.) — CBIT-in mərkəzi komponenti — xəbərdarlıq təlimi + rəqib cavab. Hər tik üçün ayrı rəqib davranış (məs. boyun atma yerinə boyunun mərkəzdə tutulması).
3. Tiklər üçün Ekspozisiya və Reaksiyanın Qarşısının Alınması (ERP — ekspozisiya və reaksiyanın qarşısının alınması) — HRT-yə alternativ davranış yanaşması — pasiyent premonitor hissi tikə cavab vermədən tab gətirməyi öyrənir. Verdellen C.W. və b. Behav Res Ther 2004. ESSTS — alternativ sübutlu davranış metodu.
4. Yale Qlobal Tik Şiddət Şkalası (ing. Yale Global Tic Severity Scale, YGTSS) — Lekman (Leckman J.F.) və b., 1989 — Tikli pozuntularda qızıl standart şiddət şkalası; motor və vokal tiklər üçün ayrı-ayrılıqda sayı, tezliyi, intensivliyi, mürəkkəbliyini, maneə olma dərəcəsini (0–5 bal); global pozulma 0–50. İlkin göstəricilər və izləmə.
5. Tiklərdən Öncəki Qabaqlayıcı İstək Şkalası (ing. Premonitory Urge for Tics Scale, PUTS) — Vuds (Woods D.W.), Piaçentini (Piacentini J.) — 9 maddəlik özünüqiymətləndirmə; qabaqlayıcı hissin intensivliyi və gündəlik fəaliyyətə maneə olma dərəcəsi.
6. Dərin Beyin Stimulyasiyası (ing. DBS — Deep Brain Stimulation) — Refrakter ağır Turret üçün cərrahi müdaxilə; tipik hədəflər — talamus (centromedian-parafascicular) və globus pallidus internus (GPi). multidissiplinar seçim; Schrock L.E. və b. Mov Disord 2015 beynəlxalq konsensus.
7. Botulinum toksini — fokal motor (məs. boyun, dodaq, göz) və vokal tiklərdə hədəf əzələyə inyeksiya; effekt 3–4 ay davam edir. Marras C. və b. Neurology 2001 RKİ.

8.7 Mənbələr arasında fərqlər

- AAN 2019 (Pringsheim Neurology 2019): CBIT birinci sıra qeyri-farmakoloji; α2-aqonistlər antipsixotiklərdən əvvəl təyin edilir, çünki yan təsir profili əlverişlidir; komorbid DDHP-də ikiqat fayda.
- ESSTS 2022 (Müller-Vahl): Avropa kontekstində; CBIT və farmakoterapiya seçimi pasiyent xüsusiyyətlərinə görə fərdiləşdirilir.
- Piacentini J. və b. JAMA 2010 (CBIT pivotal RKİ): n=126, 9–17 yaş — CBIT plasebo və dəstək terapiyası ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə üstün olmuşdur; YGTSS-də YGTSS üzrə 7,6 bala qarşı 3,5 bal azalma; effekt ölçüsü g = 0,68.
- Amerika Turret Assosiasiyasının Davranış Elmləri Konsorsiumu — CBIT proqramının tətbiqi və terapevtlərin hazırlanması üzrə tövsiyələr verilir.

9. Proqnoz

Yaxşı proqnoz amilləri

- Tipik tikli pozuntu (sürətli funksional tikbənzər davranışdan fərqli olaraq).
- Yüngül–orta YGTSS şiddəti.
- Komorbidliyin (DDHP, OKP) aktiv idarə edilməsi.
- Erkən psixoedukasiya və ailə-məktəb dəstəyi.
- CBIT əlçatanlığı.

Pis proqnoz amilləri

- Ağır komorbidlik (ağır OKP, DDHP, narahatlıq, depressiya).
- Özünə zərər vuran tiklər (məsələn, baş vurma).
- Sosial və akademik məhdud uyğunlaşma.
- Farmakoterapiyaya refrakter cavab.

İzləmə hədəfləri

- YGTSS hər 3–6 ayda.
- Komorbidlik (DDHP, OKP, narahatlıq, depressiya) — illik.
- Yan təsirlərin monitorinqi (antipsixotik qəbul edən pasiyentlərdə — metabolik, EKPS, prolaktin, QTc).
- Sosial və akademik dəstək.
- Yeniyetməlikdə spontan azalma ehtimalı; farmakoterapiyanın tədricən azaldılması mümkünlüyü.
- Yetkin pasiyentlərdə peşə fəaliyyəti və şəxsiyyətlərarası münasibətlər sahəsində dəstək.

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya mifləri

Mif 1: «Turret sindromu mütləq koprolaliya (söyüş kəlmələri) ilə müşayiət olunur»

Niyə yayılmışdır: kütləvi mediada (film, televiziya) Turret obrazının demək olar ki, həmişə koprolaliya ilə təqdim edilməsi; sensasiyaya əsaslanan media seçimi.

Klinik və bioloji məntiq: koprolaliya — kompleks vokal tikin nadir formasıdır; əksər Turret pasiyentlərində nə motor, nə də vokal tiklər ədəbsiz xarakter daşıyır.

Sübut: Freeman R.D. və b. Dev Med Child Neurol 2009 — Beynəlxalq Turret Sindromu Birliyinin məlumat bazası n=597: koprolaliya kişilərin 19,3%-ində, qadınların 14,6%-ində rast gəlinir.

Real klinik addım: ailə və məktəbin düzgün məlumatlandırılması; pasiyentin sosial stiqmasını azaltmaq.

Mif 2: «Turret — pis tərbiyə və ya valideyn səhvinin nəticəsidir»

Sübut: irsilik əmsalı 0,77-dir (Mataix-Cols JAMA Psychiatry 2015) — psixiatrik pozuntular arasında ən yüksək göstəricidir. Genetik və neyrobioloji əsaslıdır; valideynlik tərbiyəsi etiologiyanın səbəbi deyil.

Mif 3: «Turret — emosional travma və ya stress nəticəsində yaranır»

Klinik məntiq: stress tiklərin başlanğıcına səbəb deyil — tiklər genetik və neyroinkişaf əsaslıdır. Lakin stress mövcud tiklərin şiddətinə təsir göstərir.

Mif 4: «Bütün tiklər PANDAS-dır və antibiotika ilə müalicə olunmalıdır»

Niyə yayılıb: 1990-cı illərdə Susan Swedo və həmkarlarının PANDAS (streptokokk infeksiyası ilə əlaqəli pediatrik autoimmun neyropsixiatrik pozuntular) hipotezi və alternativ klinikaların marketinq fəaliyyəti bu inancın yayılmasına səbəb olmuşdur.

Klinik və bioloji məntiq: klassik PANDAS-ın klinik təzahürləri — sürətli (saat–gün) başlanğıc OKP/tik + emosional labillik + post-streptokokk infeksiya — nadir hadisədir. Əksər tikli pasiyentlər tipik gediş (tədricən başlanğıc, «güclənmə və zəifləmə» (waxing and waning)) göstərir.

Sübut: ABŞ Milli Ruhi Sağlamlıq İnstitutunun (NIMH) 2017-ci il PANDAS/PANS üzrə klinik bəyanatı: rutin antistreptolizin O testi və ya antibiotiklə profilaktika ümumi tikli pozuntularda tövsiyə edilmir; yalnız klassik klinik təzahürlər varsa qiymətləndirilir. Venadaxili immunoqlobulinin (IVIG) və plazmaferezin rutin istifadəsi sübutlu deyil (yalnız klinik tədqiqat çərçivəsində).

10.2 Zərərli və ya yanlış üsullar

Mif 5: «Tik vurduqda uşağı sərt danlamaq və ya cəzalandırmaq tikləri keçirər»

Klinik məntiq: tiklər qismən iradi saxlana bilər, lakin uzunmüddətli saxlama daxili gərginliyin artmasına və sonrakı «geri sıçrayış» (rebound) şəklində tik güclənməsinə gətirir. Cəza tikləri azaltmır, əksinə şiddətlə əlaqəli stressi artırır.

Sübut: AAN 2019, ESSTS 2022 — tiklər iradi davranış deyil; cəza yanaşması təsirli deyil və zərərlidir.

Mif 6: «Antipsixotik haloperidol bütün tikli pasiyentlərdə birinci sıra olmalıdır»

Sübut: AAN 2019 (Pringsheim) — α2-aqonistlər (klonidin, quanfasin) antipsixotiklərdən əvvəl tövsiyə edilir, yan təsir profili əlverişli olduğu üçün. Haloperidol və pimozid ABŞ Qida və Dərman İdarəsi (FDA) tərəfindən təsdiqlənmişdir, lakin EKPS, tardiv diskineziya, sedasiya, prolaktin və QTc uzanması riskləri ilə üçüncü sıra dərman kimi qəbul edilir.

Mif 7: «Stimulyantlar tiklərin alovlanmasına səbəb olur — DDHP-li Turret pasiyenti üçün stimulyant qadağandır»

Sübut: Bloch M.H. və b. JAACAP 2009 meta-analiz (n=9 RKİ, n=477) və TACT (Treatment of DDHP ilə birgə tikləri olan uşaqlar; Turret Sindromu Tədqiqat Qrupu. Neurology 2002;58(4):527–536) — orta dozada metilfenidat tikləri əhəmiyyətli gücləndirmir; bəzi pasiyentlərdə hətta tik şiddətini azaldır. Komorbid DDHP funksional pozulmanın əsas hissəsidir — stimulyantın əks göstəriş sayılması yanlışdır.

Real klinik addım: komorbid DDHP-də stimulyant təyin edilməli, tiklərin şiddəti izlənməlidir; gücləndirmə müşahidə olunarsa dozanın azaldılması və ya α2-aqonistin stimulyantla kombinasiyası.

10.3 Səmərəsiz və ya elmi cəhətdən əsassız üsullar

Mif 8: «Kannabis (medical marijuana) Turret sindromu üçün təsirli müalicə üsuludur»

Niyə yayılıb: sosial mediada anekdotik hesabatlar, kannabis sənayesinin marketinqi, bəzi pilot tədqiqatlarda kiçik təsir göstərməsi.

Sübut: Müller-Vahlın tədqiqatları (kiçik RKİ) — tetrahidrokannabinol (THC) tikləri qismən azalda bilər, lakin sübut bazası klinik tövsiyə üçün kafi deyildir. AAN 2019 — kannabinoidlər standart birinci sıra müalicə deyil; risk profili (yeniyetmələrdə psixoz riski, koqnitiv təsir, asılılıq) əhəmiyyətlidir. Yalnız refrakter yetkin hallarda və ölkənin qanunvericiliyi imkan verdikdə nəzərdən keçirilə bilər.

Mif 9: «Xüsusi pəhriz (qlütensiz, kazeinsiz) və ya qida əlavələrindən imtina Turret-ni keçirər»

Sübut: spesifik klinik sübut yoxdur; AAP, AAN tövsiyə etmir.

Mif 10: «EEQ neyroəks-əlaqə tikləri azaldır»

Sübut: sübut bazası məhduddur; AAN 2019 — birinci sıra deyil; CBIT əhəmiyyətli dərəcədə üstündür.

Mif 11: «Vitaminin meqa dozaları, omeqa-3, maqnezium tikləri keçirər»

Sübut: bu əlavələrin Turret üçün effekti sübut edilməyib; AAN 2019 və ESSTS 2022 tövsiyə etmir.

Mif 12: «Akupunktura, homeopatiya, kraniosakral terapiya Turret-ni sağaldır»

Sübut: Cochrane və sistemli icmallar — bu tamamlayıcı müdaxilələrin tikli pozuntular üçün effekti sübut edilməyib.

Mif 13: «Hipnoterapiya və ya psixoanalitik terapiya tikləri keçirər»

Sübut: 1960-cı illərə qədər üstünlük təşkil edirdi, lakin müasir sübut bazasında effektivliyi sübut olunmayıb; CBIT və ya farmakoterapiya üstündür.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və Xəstələnmə Statistikası üzrə XBT-11. 8A05.0 Birincili tikler və ya tik pozuntuları. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. Vaşinqton: APA Publishing; 2022.
3. Prinqshaym T., Okun M.S., Müller-Vahl K. və b. Təcrübə təlimatı tövsiyələrinin xülasəsi: Turet sindromu və xroniki tik pozuntuları olan şəxslərdə tiklerin müalicəsi. «Nevrologiya» (Neurology). 2019;92(19):896–906.
4. Müller-Vahl K.R., Şeyko N., Verdellen C. və b. Turet sindromu və digər tik pozuntuları üçün Avropa klinik təlimatları — versiya 2.0. «Avropa Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası» (Eur Child Adolesc Psychiatry). 2022;31(3):403–423.
5. Piaçentini C., Vuds D.V., Skahill L. və b. Turet pozuntusu olan uşaqlar üçün davranış terapiyası: randomizə olunmuş nəzarətli sınaq. «JAMA». 2010;303(19):1929–1937.
6. Vilhelm S., Peterson A.L., Piaçentini C. və b. Turet sindromu olan böyüklər üçün davranış terapiyasının randomizə olunmuş sınağı. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2012;69(8):795–803.
7. Lekman C.F., Riddl M.A., Hardin M.T. və b. Yel Qlobal Tik Ağırlığı Şkalası: tik ağırlığının həkim tərəfindən qiymətləndirilən şkalasının ilkin

sınağı. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 1989;28(4):566–573.

8. Blox M.H., Lekman C.F. Turet sindromunun klinik gedişatı. «Psixosomatik Tədqiqatlar Jurnalı» (J Psychosom Res). 2009;67(6):497–501.
9. Blox M.H., Panza K.E., Landeros-Vayzenberger A., Lekman C.F. Meta-analiz: komorbid tik pozuntuları olan uşaqlarda diqqət çatışmazlığı/hiperaktivlik pozuntusunun müalicəsi. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2009;48(9):884–893.
10. Friman R.D. və b. Turet sindromunda kopromefenomenlər. «İnkişaf Təbabəti və Uşaq Nevrologiyası» (Dev Med Child Neurol). 2009;51(3):218–227.
11. Nayt T., Stivz T., Dey L. və b. Tik pozuntularının yayılması: sistematik icmal və meta-analiz. «Pediatrik Nevrologiya» (Pediatr Neurol). 2012;47(2):77–90.
12. Matayks-Kols D., İsomura K., Perez-Vigil A. və b. Turet sindromunun və xroniki tik pozuntularının ailə riskləri: əhali əsaslı kohort tədqiqatı. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2015;72(8):787–793.
13. Yu D., Sul C.H., Tsetsos F. və b. Genom boyu assosiasiya tədqiqatları vasitəsilə Turet sindromunun və digər tik pozuntularının genetik determinantlarının öyrənilməsi. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2019;176(3):217–227.
14. Rösner V., Şenefeld K., Buse C. və b. Tik pozuntularının və Turet sindromunun farmakoloji müalicəsi. «Neyrofarmakologiya» (Neuropharmacology). 2013;68:143–149.
15. Rösner V., Plessen K.Y., Rotenberger A. və b. Turet sindromu və digər tik pozuntuları üzrə Avropa klinik rəhbərliyi. II hissə: farmakoloji müalicə. «Avropa Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası» (Eur Child Adolesc Psychiatry). 2011;20(4):173–196.
16. Turet Sindromu Tədqiqat Qrupu. Tikləri olan uşaqlarda DEQH-in müalicəsi: randomizə edilmiş nəzarətli sınaq. «Nevrologiya» (Neurology). 2002;58(4):527–536.
17. Prinqshaym T., Qanos K., MakQvayr C.F. və b. COVID-19 pandemiyası dövründə gənc qadınlarda sürətli başlanğıclı funksional tikəbənzər davranışlar. «Hərəkət Pozuntuları» (Mov Disord). 2021;36(12):2707–2713.
18. Şrok L.E., Mink C.V., Vuds D.V. və b. Turet sindromunda dərin beyin stimulyasiyası: icmal və yenilənmiş tövsiyələr. «Hərəkət Pozuntuları» (Mov Disord). 2015;30(4):448–471.

19. ABŞ Milli Ruhi Sağlamlıq İnstitutu (NIMH). həkimlər üçün PANDAS/PANS məlumatı. 2017.
20. Ezrin N.H., Nann R.Q. Vərdişin dəyişdirilməsi: sinir vərdişlərinin və tiklərin aradan qaldırılması üsulu. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1973;11(4):619–628.

6A20–6A2Z ŞİZOFRENİYA SPEKTRİ

Şizofreniya və digər ilkin psixotik pozuntular

XBT-11 **6A20**	**6A20 ŞİZOFRENİYA** **Schizophrenia**
XBT-10 F20	Şizofreniya
DSM-5-TR F20.9	Şizofreniya

1. Tərif və nozologiya

Şizofreniya — düşüncə, qavrayış, affekt və davranışın əhəmiyyətli dərəcədə pozulması ilə müşayiət olunan, ən azı bir ay davam edən aktiv fazanın simptomları və qayda olaraq xronik gedişlə xarakterizə edilən psixotik pozuntudur. XBT-11 təsnifatında 6A20 kodu ilə «Şizofreniya və digər ilkin psixotik pozuntular» (6A2Z) qrupunda yerləşir.

Nozoloji baxımdan ilkin psixotik pozuntu — yəni psixotik simptomlar başqa tibbi vəziyyət, maddə təsiri və ya affektiv pozuntu ilə tam izah edilmir. Şizoaffektiv pozuntu (6A21), şizotipik pozuntu (6A22), kəskin və keçici psixotik pozuntu (6A23) və sayıqlama pozuntusu (6A24) ondan ayrı kodlanır.

2. Tarixçə

Müasir şizofreniya konsepsiyası dörd əsas mərhələdən keçmişdir:

- Kraepelin (1899) — «dementia praecox» (erkən demensiya) — gənc yaşda başlayan, davamlı koqnitiv enmə ilə xarakterizə olunan pozuntu kimi.
- Bleuler (1911) — «şizofreniyalar» termini («yarılmış ağıl» mənasında, lakin «ikili şəxsiyyət» mənasında deyil); «4A» simptom qrupu (assosiasiya pozulması, affekt, ambivalentlik, autizm) əsas götürülmüşdür.
- Schneider K. (1959) — «1-ci dərəcəli simptomlar» (səs-düşüncə, şərhedici hallüsinasiyalar, fikir oğurluğu, nəzarət hissi) diaqnostik prioritet kimi qəbul edilmişdir; DSM-III və XBT-10-da bu yanaşma əks olunmuşdur.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — alt-tiplər (paranoid, hebefrenik, katatonik, sadə) ləğv edilmişdir (klinik faydalılığı sübut olunmamışdır, gediş

zamanı dəyişkəndir); Şneyderin 1-ci dərəcəli simptomları digər simptomlarla bərabər statusa salınmışdır; XBT-11-də əlavə olaraq ölçülü yanaşma tətbiq edilmişdir — 6A25 simptom domenləri (pozitiv, neqativ, depressiv, manik, psixomotor, koqnitiv) və 6A20.x gediş kvalifikatorları.

XBT-10 (F20) ilə müqayisədə əsas dəyişikliklər: alt-tiplərin ləğvi, Şnayder simptomlarının xüsusi statusunun ləğvi, 1 aylıq müddət şərtinin saxlanılması, lakin DSM-5-TR-dəki 6 aylıq tələbdən fərqli olaraq, ümumi xəstəlik müddəti tələbinin olmaması.

3. Epidemiologiya

Yayılma və insidens

- Ömürlük yayılma: 0,3–0,7% (Saha S. və b. PLoS Med 2005, sistemli icmal, 188 tədqiqat, 46 ölkə).
- İllik insidens: 15,2 / 100 000 (McGrath J.J. və b. BMC Med 2004 meta-analiz).
- Coğrafi və mədəni dəyişkənlik mövcuddur, lakin əsas insidens göstəricisi müəyyən diapazonda qalır.

Cins və yaş

- Kişi: qadın nisbəti təxminən 1,4: 1; kişilərdə başlama yaşı 18–25, qadınlarda 25–35 (Aleman A. və b. Arch Gen Psychiatry 2003).
- Qadınlarda menopauzadan sonra ikinci insidens zirvəsi müşahidə olunur (estrogenin neyroprotektiv təsirinin azalması ilə əlaqələndirilir).
- Uşaqlıq dövründə başlanğıc nadirdir (bütün hadisələrin <1%-i), 50 yaşdan sonra isə ilkin diaqnoz çox seyrək qoyulur.

Komorbidlik və mortalitet

- Maddə istifadəsi pozuntusu — komorbid təxminən 50% (xüsusilə tütün, kannabis, alkohol).
- Depressiya gediş ərzində komorbidlik kimi 25–80% hallarda müşahidə olunur.
- İntihar (suisid): ömürlük risk təxminən 5–10% (Hor K., Taylor M. J Psychopharmacol 2010); ən yüksək risk ilk 5 il ərzindədir.
- Ümumi mortalitet: əhali (populyasiya) ilə müqayisədə 2–3 dəfə yüksək; orta gözlənilən ömür 15–20 il qısadır (Olfson M. və b. JAMA Psychiatry 2015) — əsasən kardiovaskulyar xəstəliklər, metabolik sindrom, tütün istifadəsi.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

İrsilik 60–80% (Sullivan P.F. və b. Arch Gen Psychiatry 2003, əkiz meta-analizi). Monoziqot əkizlərdə konkordans təxminən 50%, diziqotda təxminən 15%, ümumi əhali riski təxminən 1%. Bir valideyndə şizofreniya — uşaqda risk təxminən 10%; hər iki valideyndə — təxminən 40%.

Poliqen təbiət: genom boyu assosiasiya tədqiqatları (GWAS) 200+ risk lokusu aşkar etmişdir (Trubetskoy V. və b. Nature 2022, n>76 000 pasiyent (hal)). Tək gen «şizofreniya geni» yoxdur — risk yüzlərlə kiçik təsirli variant və nadir nüsxə sayı variantları (CNV) — 22q11.2 delesiyası (təxminən 25 dəfə artmış risk), 16p11.2, NRXN1 delesiyaları.

4.2 Neyroinkişaf modeli

Şizofreniya — neyroinkişaf pozuntusu kimi qəbul edilir (Weinberger D.R. Arch Gen Psychiatry 1987; Murray R.M., Lewis S.W. BMJ 1987). Erkən beyin inkişafındakı pozulma (intrauterin və erkən postnatal) gənc yaşda klinik təzahürə gətirib çıxarır. Sübutlar:

- Premorbid koqnitiv çatışmazlıq və motor gecikmələr — uşaqlıqdan sənədləşdirilmişdir.
- Sinaptik budanma (pubertat dövründə) həddindən artıq güclənir — kortikal boz maddə kütləsinin azalması.
- İlk epizodda artıq beynin struktur dəyişiklikləri qeydə alınır (vasitəçi deyil — göstəricidir).

4.3 Mühit risk amilləri

- Obstetrik fəsadlar — hipoksiya, infeksiya, dölün inkişafının geriliyi (Cannon M. və b. Am J Psychiatry 2002 meta-analiz, OR təxminən 2).
- Ananın hamiləliyi dövründə keçirilən virus infeksiyaları (qrip, herpes) — riski 2–7 dəfə artırır (Brown A.S. Schizophr Bull 2006).
- Yetkinlik dövründə kannabis istifadəsi — psixoz riskini 2–3 dəfə artırır, xüsusilə erkən yaşda və yüksək THC dozasında (Marconi A. və b. Schizophr Bull 2016 meta-analiz).
- Şəhər mühitində böyümə, miqrasiya, sosial izolyasiya, uşaqlıq travması orta dərəcəli risk artımı ilə əlaqələndirilir (van Os J. və b. Nature 2010 icmal).
- Ata yaşının 45-dən yuxarı olması yeni mutasiya riski ilə əlaqəlidir (Malaspina D. Arch Gen Psychiatry 2001).

4.4 Neyrobioloji mexanizmlər

- Dopamin hipotezi (yenilənmiş): mezolimbik dopamin hiperaktivliyi pozitiv simptomlara səbəb olur; mezokortikal hipoaktivlik isə neqativ və koqnitiv simptomlara; mezokortikal *hipoaktivlik* → neqativ və koqnitiv simptomlar (Howes O.D., Kapur S. Schizophr Bull 2009).
- Qlutamat NMDA hipofunksiyası: ketamin və PCP NMDA blokadası ilə şizofreniyabənzər simptomlar yaradır; bu, qlutamat sistemini ikinci əsas mexanizm kimi önə çıxarır (Olney J.W., Farber N.B. Arch Gen Psychiatry 1995).
- Qamma-aminobutirik turşu (GABA) ilə işləyən interneyronlar: parvalbumin-müsbət interneyronların disfunksiyası prefrontal qabıqda işlək yaddaş pozuntusuna gətirib çıxarır.
- Struktur dəyişikliklər: kortikal boz maddə həcminin azalması (xüsusilə prefrontal və yuxarı temporal qabıq), ventrikül genişlənməsi, hipokamp həcminin azalması (Haijma S.V. və b. Schizophr Bull 2013, meta-analiz n>8000).
- İltihab nəzəriyyəsi: CRP, IL-6 yüksəkliyi və mikroglia aktivasiyası ilkin epizodlarda sənədləşdirilmişdir (Khandaker G.M. və b. Lancet Psychiatry 2015).

5. Klinik təzahürlər

Simptom sahələri (XBT-11 / 6A25)

Pozitiv simptomlar

Sayıqlama (təqib, münasibət, böyüklük, nəzarət), hallüsinasiyalar (ən tipik eşitmə — şərh xarakterli səslər və ya dialoq), düşüncə formal pozuntusu (dezorqanizə olunmuş nitq, neologizmlər, «söz salatı»), kobud dezorqanizə olunmuş davranış.

Neqativ simptomlar

Affektiv yastılıq, avolisiya (motivasiyanın itməsi), aloqiya (nitqin yoxsullaşması), anhedoniya, sosial geri çəkilmə. Funksional pozulmanın əsas amilidir; farmakoterapiyaya zəif cavab verir.

Koqnitiv simptomlar

İşlək yaddaş, diqqət, icra funksiyası, semantik və epizodik yaddaş pozulmaları. Pasiyentlərin 75–85%-ində mövcuddur (Heinrichs R.W., Zakzanis K.K. Neuropsychology 1998 meta-analiz).

Depressiv və manik simptomlar

Affektiv epizodlar şizofreniya gedişində geniş yayılmışdır; affektiv epizod psixotik simptomları izah etmirsə — şizofreniya diaqnozu qalır.

Psixomotor simptomlar

Katatonik komponentlər (mutizm, neqativizm, mumvari elastiklik, stereotipiya), agitasiya, lənglәmə.

Xəstəliyin mərhələləri

1. Premorbid faza — uşaqlıqdan başlayan diskret koqnitiv və sosial çatışmazlıq (klinik şizofreniya hələ yoxdur).
2. Prodromal faza — aylar–illər; sosial geri çəkilmə, qəribə təcrübələr, depressiv əlamətlər, subklinik psixotik simptomlar.
3. Kəskin (ilk) psixotik epizod — açıq pozitiv simptomlar; orta başlanğıc yaşı 18–25 (kişilərdə).
4. Stabilizasiya və residual fazalar — qalıq simptomlar, funksional məhdudiyyət, residiv epizodlar.

«1/3 prinsipi» (Hegarty J.D. və b. Am J Psychiatry 1994 icmal)

- təxminən 1/3 pasiyent — yaxşı funksional bərpa.
- təxminən 1/3 — qalıq simptomlar, qismən funksional bərpa.
- təxminən 1/3 — ağır xronik gediş, davamlı dəstək tələbi.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11, NICE CG178 konsensusu)

A. Aktiv fazanın simptomları — aşağıdakılardan ən azı 2-si ≥ 1 ay davam etmiş olmalıdır; ən azı biri (1)–(3)-dən seçilməlidir:

1. Sayıqlama
2. Hallüsinasiyalar
3. Düşüncə formal pozuntusu / dezorqanizə nitq
4. Kobud dezorqanizə və ya katatonik davranış
5. Neqativ simptomlar (affektiv yastılıq, avolisiya, aloqiya)

B. Funksional pozulma — iş, münasibət və ya özünə baxım sahələrinin birində və ya bir neçəsində əhəmiyyətli azalma.

C. İstisnalar — psixoaktiv maddə təsiri və üzvi səbəb (toksikoloji skrininq, beyin görüntüləməsi, laboratoriya müayinələri) istisna edilməlidir.

D. Affektiv diferensiasiya — affektiv epizod psixotik simptomları tam izah etmir (şizoaffektiv pozuntu və ya psixotik xüsusiyyətləri olan affektiv pozuntu kənara qoyulur).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR (F20.9) əlavə tələbi: ümumi xəstəlik müddəti ≥ 6 ay (1 ay aktiv simptomlar, prodromal və ya qalıq simptomlar). Autizm spektri və ya nitq pozuntusu fonunda — şizofreniya yalnız aydın sayıqlama və ya hallüsinasiya əlavə olaraq mövcud olduqda kodlanır.
- XBT-11 (6A20) fərqi: ≥ 1 ay aktiv simptom kifayətdir, ümumi 6 aylıq tələb yoxdur. Alt-tiplər ləğv edilmişdir; əvəzində 6A25 simptom domenləri və 6A20.x gediş kvalifikatorları (0 ilk epizod kəskin, 1 ilk epizod qismən və ya tam remissiyada, 2 çoxsaylı epizod, 3 davamlı, Z spesifikləşdirilməyib) kodlanır.
- NICE CG178 praktika tələbi: diaqnoz klinikdir, lakin strukturlaşdırılmış müsahibə (SCID-5 və ya MINI) və şiddət şkalası (PANSS və ya BPRS) ilə dəstəklənməlidir; ilk epizodda beyin MRT, EKG, metabolik ilkin göstəricilər (qlükoza, HbA1c, lipid, prolaktin) məcburidir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (pasiyent + ən azı bir məlumatlı qohum).
2. Strukturlaşdırılmış diaqnostik müsahibə (SCID-5 və ya MINI).
3. Şiddət qiymətləndirməsi (PANSS və ya BPRS ilkin qiyməti).
4. Cismani və neyroloji müayinə.
5. Toksikoloji skrininq (sidik) və maddə istifadəsi tarixçəsi.
6. Mütləq laborator (aşağıda § 7.2).
7. Beyin MRT (ilk epizodda).
8. Differensial diaqnostika (§ 6.4).
9. Komorbidlik və intihar riskinin qiymətləndirilməsi (Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası (C-SSRS)).
10. Funksional səviyyə qiymətləndirməsi (GAF və ya PSP).

6.4 Differensial diaqnostika

Pozuntu	Fərqləndirici əlamətlər
Şizoaffektiv pozuntu (6A21)	Affektiv epizod psixotik simptomların əhəmiyyətli hissəsində mövcud, lakin psixoz affektiv epizoddan kənar dövrlərdə də qalır.
Şizotipik pozuntu (6A22)	Psixotik-bənzər simptomlar; tam psixoz meyarları yoxdur; davamlı şəxsiyyət xüsusiyyətləri.
Sayıqlama pozuntusu (6A24)	Yalnız sayıqlama, hallüsinasiya minimal və ya yox; funksiya nisbi saxlanılır.
Kəskin və keçici psixotik pozuntu (6A23) — sayıqlama pozuntusundan (6A24) əvvəl yerləşdirilməlidir	Davametmə müddəti ≤ 3 ay (XBT-11) və ya < 1 ay (DSM-5-TR — qısa psixotik pozuntu).
Affektiv pozuntu psixotik xüsusiyyətlərlə (6A60.x, 6A70.x)	Psixoz yalnız manik və ya depressiv epizod kontekstində mövcuddur.
Maddə induksiyalı psixoz (6C4x)	Maddə istifadəsi və ya kəsilməsi ilə zaman bağlılığı; maddə eliminasiyasından sonra remissiya.
İkincili (üzvi) psixotik sindrom (6E61)	Tibbi vəziyyət (epilepsiya, autoimmun ensefalit, beyin şişi, Wilson xəstəliyi) ilə əlaqəli.
Autizm spektri pozuntusu (6A02)	Erkən başlanğıc, sosial-kommunikativ çatışmazlıq əsas; hallüsinasiya/sayıqlama tipik deyil.
Şəxsiyyət pozuntuları (6D10) — paranoid və ya şizoid xüsusiyyətlərlə	Davamlı şəxsiyyət xüsusiyyətləri, tam psixotik epizodlar yoxdur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik müsahibə və şkalalar

- Strukturlaşdırılmış müsahibə: SCID-5 (DSM-5 üçün), MINI (qısa, klinik praktikada əlçatan).
- Şiddət (qızıl standart): PANSS (30 göstərici, 7 ballıq şkala), BPRS (18 göstərici), SANS/SAPS (neqativ və pozitiv simptomlar ayrı-ayrı), CGI-S.

- Funksional səviyyə: GAF (DSM-IV), Şəxsi və sosial fəaliyyət şkalası (PSP).
- İntihar riski: Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası (C-SSRS).
- Koqnitiv qiymətləndirmə: MATRICS koqnitiv batareyası (MCCB) — araşdırma və ixtisaslaşdırılmış klinikalarda.

7.2 Laborator müayinələr

İlk epizodda mütləq: tam qan analizi, qaraciyər və böyrək funksiyası, acqarnı qlükoza və HbA1c, lipid profili, TSH və T4, vitamin B12 və folat, toksikoloji skrininq (kannabis, amfetamin, opioid, kokain, fensiklidin (PCP), ekstazi (MDMA)), HIV və sifilis serologiyası, hamiləlik testi (qadınlarda), prolaktin ilkin qiyməti.

Selektiv (klinik şübhə əsasında): EEQ (epileptik tutmaları və ya deliriumu istisna etmək üçün), anti-NMDA-R antikorları (BOS — beyin onurğa mayesi), seruloplazmin və 24 saatlıq sidikdə mis (Wilson xəstəliyi şübhəsi), B12/folat/homosistein (üzvi səbəb şübhəsi).

7.3 İnstrumental müayinələr

- Beyin MRT (T1, T2, FLAIR) — ilk epizodda tövsiyə edilir (NICE CG178).
- EKG — antipsixotik müalicəyə başlamazdan əvvəl (QTc ilkin qiyməti).
- Beyin KT — MRT əlçatan olmadıqda.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG178, APA 2021, WFSBP 2015, Maudsley 14e konsensusu)

1. Multimodal yanaşma — farmakoterapiya + psixososial müdaxilə + sistemli dəstək. Tək farmakoterapiya funksional bərpa üçün kifayət deyil.
2. Pasiyentlə birgə qərar (ing. shared decision making) — preparat, doza və yan təsir profili müzakirə edilir; müalicəyə riayət bu mərhələdən başlayır.
3. İlk epizodda atipik antipsixotik üstün — aşağı dozda, tədricən titrasiya. İlk epizodda standart dozanın aşağı yarısı kifayət ola bilər.
4. Effekt qiymətləndirməsi — 2–4 həftə qismən cavab, 4–6 həftə adekvat dozada tam cavab gözlənilir. Cavab yoxdursa — preparat dəyişdirilir.
5. Monoterapiya — antipsixotik polipraqmaziya yan təsir yükünü artırır, effekt sübutu zəifdir; klozapinə ikinci antipsixotikin əlavə edilməsi istisna təşkil edə bilər.
6. Müalicə-rezistent şizofreniya (TRS) — iki müxtəlif antipsixotikə adekvat doza və müddətdə (hər biri 4–6 həftə, zəif cavabda 8 həftəyə qədər) cavabsızlıq — klozapin başlanır.

7. Dəstəkci müalicə — ilk epizoddan sonra ən azı 1–2 il, çoxsaylı epizoddan sonra uzunmüddətli/ömürlük. Antipsixotikin kəsilməsi residiv riskini kəskin artırır: bir il ərzində residiv davamlı antipsixotik qəbulunda 27%, kəsmə və ya plasebo halında 64% (Leucht S. və b. Lancet 2012, 65 tədqiqat, n=6493; RR 0,40).
8. Psixososial müdaxilə — KDTp və ailə müdaxiləsi bütün pasiyentlərə təklif edilməlidir (NICE CG178 — güclü tövsiyə).
9. Sistemli monitorinq — metabolik göstəricilər, EKPS, prolaktin, elektrokardioqramma (EKQ).
10. LAI (uzunmüddətli təsirli inyeksiya) — müalicəyə riayət problemində və ya pasiyent seçimi ilə; ilk epizoddan sonra residiv profilaktikasında daha yaxşı nəticə (Tiihonen J. və b. JAMA Psychiatry 2017).

8.2 Farmakoterapiya — birinci xətt antipsixotiklər

Hər preparat üçün mexanizm, doza, sübut və yan təsir profili.

Preparat	Reseptor profili	Standart doza (mq/gün)	Əsas yan təsirlər	Üstünlük
Olanzapin	D2, 5-HT2A, H1, M1	5–20 mq/gün	Çəki artımı, metabolik sindrom, sedasiya	Yüksək effekt, lakin metabolik risk yüksək
Risperidon	D2, 5-HT2A	2–6 mq/gün	EKPS (doza > 6 mq), hiperprolaktinemiya	Geniş istifadə, ucuz, LAI variantı mövcud
Aripiprazol	D2 qismən agonist, 5-HT1A agonist, 5-HT2A antaqonist	10–30 mq/gün	Akatiziya, başgicəllənmə	Metabolik profil yaxşı, prolaktin neytral
Kvetiapin	D2 (zəif), 5-HT2A, H1, α1	300–800 mq/gün	Sedasiya, ortostatik hipotoniya, çəki artımı	Yumşaq EKPS profili
Paliperidon	Risperidonun aktiv metaboliti	6–12 mq/gün	Hiperprolaktinemiya, EKPS	LAI (aylıq, 3 aylıq, 6 aylıq) variantları

Preparat	Reseptor profili	Standart doza (mq/gün)	Əsas yan təsirlər	Üstünlük
Lurasidon	D2, 5-HT2A, 5-HT7	40–160 mq/gün (yeməklə)	Akatiziya, ürəkbulanma	Metabolik profil çox yaxşı; yeməklə qəbul mütləq
Ziprasidon	D2, 5-HT2A, 5-HT1A	80–160 mq/gün	QTc uzanması	EKG monitorinqi tələb edir

Tipik (I nəsil) antipsixotiklər — haloperidol 5–20 mq/gün, xlorpromazin 200–800 mq/gün, flupentiksol 6–18 mq/gün, zuklopentiksol 25–150 mq/gün. Pozitiv simptomlarda effektivdir, lakin EKPS, tardiv diskineziya və neqativ simptomlara təsiri zəifdir; atipik antipsixotik əlçatan olduqda tipik preparatlar üstün sayılmır.

Mexanizm üzərinə qeyd: bütün antipsixotiklərin əsas mexanizmi mezolimbik D2 reseptor antaqonizmidir (atipiklərdə əlavə 5-HT2A antaqonizmi — neqativ simptomlara və EKPS azaldılmasına töhfə verir). 60–80% D2 işğalı terapevtik diapazondur; > 80% EKPS riski artır; < 60% effekt yetərsizdir (Kapur S., Mamo D. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2003).

8.3 Müalicə-rezistent şizofreniya və klozapin

Klozapin — müalicəyə rezistent şizofreniyada (MRS) sübuta əsaslanan yeganə üstün preparatdır (Kane J. və b. Arch Gen Psychiatry 1988 ilkin RKİ; Siskind D. və b. Br J Psychiatry 2016 meta-analiz). TRS pasiyentlərinin 30–60%-i klozapinə cavab verir.

Niyə üstündür: D2 işğalı aşağı (40–60%), lakin müxtəlif reseptorlara (D4, 5-HT2A, M1, α1) güclü təsir; daha az EKPS, neqativ simptomlarda daha yaxşı effekt; intiharı azaltma (FDA göstərişi).

Başlanma protokolu: 12,5 mq başlanğıc; tədricən 200–450 mq/günə artır (max 900 mq/gün). Tam qan + leykosit formulu — həftəlik ilk 18 həftə, sonra 2 həftədə bir 1 ilə qədər, sonra aylıq. Neytrofil 1000–1499 1 μL qanda 1000–1499 neytrofil — yüngül neytropeniya, gücləndirilmiş nəzarətlə davam; < 1000 /μL → müalicəyə ara verilir; < 500 /μL → ağır neytropeniya. Xoşxassəli etnik neytropeniyada hədd < 500 /μL.

Klozapinin yan təsirləri və onların idarə edilməsi:

- Aqranulositoz (təxminən 0,8%, mortalitet 5%) — qan formulu monitorinqi.
- Miokardit — xüsusilə ilk 4 həftədə; troponin, EKG.
- Konstipasiya — ileus və perforasiya riski; profilaktik laksativ.

- Hipersalivasiya, sedasiya — dozaya uyğunlaşır.
- Tutmalar — > 600 mq/gün dozada risk artır; EEQ yoxlaması.
- Metabolik sindrom — yüksək; mütəmadi monitorinq.

Klozapinin kəsilməsi — vacib klinik məqam: birdən-birə kəsmə rikoşet psixozu (orijinal simptomlardan ağır), xolinergik rikoşet (ürəkbulanma, qusma, ishal) və adrenergik rikoşet (aqitasiya, yuxusuzluq) yaradır. Aqranulositozda kəsilməlidirsə — pasiyent stasionarda paralel digər antipsixotikə (olanzapin və ya kvetiapin) tədricən keçirilir. Plan üzrə kəsmədə — hər 1–2 həftədə dozanın 10–25% azaldılması.

8.4 LAI (uzunmüddətli təsirli inyeksiya) variantları

LAI	İnterval	Standart doza
Risperidon LAI (uzunmüddətli təsirli inyeksiya forması)	2 həftədə bir	25–50 mq
Paliperidon palmitat	Aylıq / 3 aylıq / 6 aylıq	75–150 mq aylıq
Aripiprazol LAI (aylıq inyeksiya forması)	Aylıq	400 mq
Olanzapin pamoat	2–4 həftədə bir	150–300 mq
Haloperidol dekanoat	4 həftədə bir	50–200 mq
Flupentiksol dekanoat	2–4 həftədə bir	20–40 mq
Zuklopentiksol dekanoat	2–4 həftədə bir	200–400 mq

8.5 Kəskin psixomotor aqitasiyanın idarə edilməsi

- Oral (üstün): lorazepam 1–2 mq + olanzapin 5–10 mq ağızda dağılan tablet və ya risperidon 1–2 mq oral məhlul.
- Əzələdaxili: olanzapin im 10 mq və ya aripiprazol im 9,75 mq və ya haloperidol 5 mq + lorazepam 2 mq im (klassik).
- Diqqət: olanzapin im + benzodiazepin parenteral — respirator depressiya riski; eyni vaxtda istifadə edilməməlidir.

8.6 Yan təsirlərin idarəsi

Ekstrapiramidal simptomlar (EKPS):

Simptom	Klinik təzahür	Müdaxilə
Akut distoniya	Boyun, dil, göz əzələləri spazmı (ilk saatlar–günlər)	Biperiden 2–5 mq im (təcili)
Parkinsonizm	Tremor, rigidlik, bradikineziya	Doza azaltma; biperiden 2–4 mq/gün
Akatiziya	Daxili narahatlıq, oturmama	Propranolol 30–80 mq/gün; doza azaltma
Tardiv diskineziya	Gec başlayan diskinetik hərəkətlər (aylar–illər)	Valbenazin / deutetrabenazin; klozapinə keçid

Metabolik yan təsir: çəki, bel ölçüsü, qan təzyiqi — aylıq ilk 6 ay, sonra 6 aylıq; ac qlükoza, HbA1c, lipid — başlanğıc, 12 həftə, sonra ildə bir. Müdaxilə: pəhriz və fiziki fəaliyyət konsultasiyası, metformin (artıq çəkidə), antipsixotikin metabolik neytral preparata dəyişdirilməsi (aripiprazol, lurasidon).

Hiperprolaktinemiya: yüksək risk — risperidon, paliperidon, amisulpirid, tipiklər; aşağı risk — aripiprazol, kvetiapin, klozapin. Simptomlu hallarda (galaktoreya, amenoreya, cinsi disfunksiya, osteoporoz) — preparatı dəyişdir.

Antipsixotik malign sindrom (AMS) — təcili tibbi vəziyyət (mortalitet 10%-ə qədər): klinik tetrada — hipertermiya, əzələ rigidliyi, şüur dəyişikliyi, autonom qeyri-sabitlik. Laborator: CPK > 1000, leykositoz, mioqlobinuria. Müdaxilə: antipsixotikin dərhal kəsilməsi, intensiv terapiya dəstəyi, dantrolen, bromokriptin, lazımdırsa EKT.

8.7 Xüsusi vəziyyətlər

- Hamiləlik: antipsixotikin tam kəsilməsi residiv riskini artırır. Sinif olaraq antipsixotiklər anadangəlmə qüsur riskini əhəmiyyətli artırmır (Huybrechts K.F. və b. JAMA Psychiatry 2016, 1,3 mln hamiləlik); mümkün istisna — risperidon; bu siqnal təsdiq olunmamışdır və əlavə tədqiqat tələb edir. Seçim fərdidir: effekt verən preparat adətən davam etdirilir.
- Yaşlılar: EKPS, ortostatik hipotenziya, antikolinergik təsirə həssaslıq; aşağı doza, kvetiapin və ya risperidon üstün; Beers meyarlarına nəzər salın.
- Komorbid psixoaktiv maddə istifadəsi: tütündən imtina dəstəyi, kannabisin kəsilməsi, alkohol asılılığı paralel müalicə edilir (naltrekson 50 mq/gün, akamprosat 1998 mq/gün).

8.8 Müalicə metodikaları

1. Psixoz üçün koqnitiv-davranış terapiyası (KDTp / CBTp — ing. Cognitive Behavioural Therapy for psychosis) — Psixotik simptomları «düşüncə–emosiya–davranış» formulasiyası daxilində yenidən qiymətləndirmə; pasiyent hallüsinasiyaları və sayıqlamaları reallıq sınaqları, davranış eksperimentləri və alternativ izah axtarışı ilə ünvanlayır. Standart kurs — 16+ fərdi seans, 6–12 ay. Effekt: pozitiv simptomlarda kiçik-orta effekt (NICE CG178, orta keyfiyyətli sübut), funksional səviyyədə təkmilləşmə (Wykes T. və b. Schizophr Bull 2008, n=2284 meta-analiz; NICE CG178 § 1.3.7.1).
2. Ailə Müdaxiləsi (ing. Family Intervention) — Yüksək emosional ekspressiya (EE) olan ailələrdə psixoedukasiya, ünsiyyət təlimi və problem-həll. Pasiyent + ən azı bir ailə üzvü, 10+ seans, 3–12 ay. Effekt: residiv riskini təxminən 20% azaldır, xəstəxana yatımını azaldır (Pharoah F. və b. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD000088, n>3500). NICE CG178 § 1.3.7.2.
3. Koqnitiv Remediasiya (ing. Cognitive Remediation) — Kompüter və ya təlimçi-əsaslı strukturlaşdırılmış koqnitiv məşqlər — diqqət, işlək yaddaş, icra funksiyası, sosial koqnisiya. 20–40 seans, həftədə 2–3 dəfə. Effekt: koqnitiv göstəricilərdə kiçik-orta artım, funksional səviyyəyə yalnız psixososial reabilitasiya ilə birgə tətbiq edildikdə keçir (Wykes T., Huddy V., Cellard C., McGurk S.R., Czobor P. Am J Psychiatry 2011;168(5):472–485, meta-analiz n=2104).
4. Dəstəkli Məşğulluq (ing. Supported Employment) / Fərdi Yerləşdirmə və Dəstək (ing. İPS / IPS — Individual Placement and Support) — Real iş yerlərində birbaşa dəstəkli işə cəlb olunma — «place-then-train» prinsipi (qabaqcadan hazırlıq mərhələsi olmadan iş axtarışına başlamaq). Şəxsi vəzifə koordinatoru, fərdi maraq və qabiliyyət əsasında iş tapmaq, iş yerində dəstək. Effekt: yarımdan çoxu rəqabətli işə daxil olur (kontrol qruplarda 20%) — Drake R.E., Bond G.R., Goldman H.H. və b. Health Aff (Millwood) 2016;35(6):1098–1105. NICE CG178 § 1.3.7.3.
5. Psixozda Erkən Müdaxilə (ing. EIP — Early Intervention in Psychosis) — İlk psixotik epizoddan sonra 3 il ərzində intensiv multidissiplinar qayğı — aşağı doza farmakoterapiya, KDTp, ailə müdaxiləsi, məşğulluq dəstəyi, həmyaşıd dəstəyi. RAISE və EDEN RKİ-ləri (Kane J.M. və b. Am J Psychiatry 2016; Marshall M. və b. Lancet 2011) — EIP standart qayğıdan üstün, residiv azaldır, funksional səviyyəni yaxşılaşdırır. NICE CG178 § 1.4.
6. Assertiv İcma Müalicəsi (ing. ACT — Assertive Community Treatment) — multidissiplinar komanda (psixiatr, klinik psixoloq, sosial işçi, həmyaşıd məsləhətçisi) pasiyentə icmada (evdə, iş yerində) intensiv dəstək göstərir;

24/7 əlçatanlıq, aşağı pasiyent/işçi nisbəti (təxminən 10:1). Hədəf: təkrar xəstəxana yatımı və evsiz qalma riski yüksək olan pasiyentlər. Effekt: xəstəxana günlərini azaldır, məskunlaşma sabitliyini artırır (Marshall M., Lockwood A. Cochrane 2011).

7. PANSS / BPRS — Şiddət şkalaları — PANSS (ing. Positive and Negative Syndrome Scale) — 30 göstərici, 7 ballıq şkala; BPRS (ing. Brief Psychiatric Rating Scale) — 18 göstərici. Strukturlaşdırılmış müsahibə əsasında psixotik simptomların kəmiyyət qiymətləndirməsi. Klinik praktikada başlanğıc qiymətləndirmə və müalicənin izlənməsi üçün istifadə olunur. Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A. Schizophr Bull 1987;13(2):261–276 (PANSS); Overall J.E., Gorham D.R. Psychol Rep 1962;10:799–812

8.9 Klinik tövsiyələr arasında fərqlər

- NICE CG178: Erkən Müdaxilə Xidmətləri (EIP) — ilk 3 il intensiv multidissiplinar dəstək; iki müxtəlif antipsixotikə cavab olmadıqda klozapin təklif edilir.
- APA 2021: dəstəkci müalicə müddəti ilk epizoddan sonra 2–5 il; koqnitiv remediasiya və dəstəkli məşğulluq funksional bərpada açıq tövsiyə edilir.
- WFSBP 2015: ekvivalent doza diapazonları və adekvat müddət (4–6 həftə) preparat dəyişiminə qədər; LAI residiv profilaktikasında effektivlik.
- Maudsley 14e (2021): klozapin titrasiyası, yan təsir idarəsi və polipraqmaziya səbəbləri üzrə ətraflı protokol.
- Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Klinik Protokolu (2009): atipik antipsixotik birinci sıra; ənənəvi (tipik) antipsixotiklər yalnız atipik preparatlar əlçatan olmadıqda tətbiq edilir. Ümumi alqoritm NICE/APA ilə üst-üstə düşür.

9. Proqnoz

Yaxşı proqnoz amilləri

- Qısa müalicəsiz dövrü (DUP < 6 ay)
- Kəskin başlanğıc, aydın stress amili
- Premorbid yaxşı funksiya
- Pozitiv simptomların üstünlüyü (neqativ az)
- Affektiv komponentin mövcudluğu
- Yaxşı sosial dəstək, ailə əməkdaşlığı
- Erkən müdaxilə və müalicəyə riayət

Pis proqnoz amilləri

- Tədricən başlanğıc, uzun prodrom
- Erkən başlama yaşı (uşaq və yeniyetmə dövrü)
- Premorbid funksional zəiflik (uşaqlıqdan)
- Neqativ simptomların üstünlüyü
- Koqnitiv defisitinin ağırlığı
- Maddə istifadəsi (xüsusilə kannabis, amfetamin)
- Adhesiyasızlıq, sosial izolyasiya
- DUP > 1 il

İzləmə hədəfləri

- Klinik stabillik və residiv profilaktikası (antipsixotik müalicəsinə riayət, LAI nəzərdən keçirilməsi).
- Metabolik və kardiovaskulyar riskin idarə edilməsi (mortalitetə əsas töhfə verən amildir).
- Funksional bərpa — məşğulluq, müstəqil yaşayış, sosial əlaqələr.
- Komorbid maddə istifadəsi, depressiya, intihar riski monitorinqi.
- Ailə və icma dəstək sistemlərinin gücləndirilməsi.

10. Miflər və yanlış təsəvvürlər

10.1 Xəstəliyin mənşəyi ilə bağlı miflər

Mif 1: «Şizofreniya — ruhların ələ keçirməsi və ya cin tutmasıdır»

Niyə yayılıb: Tarixi-dini kontekst — Avropa Orta əsrlərində psixoz «şeytan tutması» kimi izah edilirdi; hallüsinasiyaların subyektiv xarakteri, psixiatrik xidmətə əlçatanlığın aşağı olması, ailənin ilk növbədə dini liderə müraciət etməsi ailə ilk növbədə dini liderə müraciət edir.

Klinik və bioloji məntiq: Şizofreniya ölçülə bilən neyrobioloji əlamətlərə malikdir — kortikal boz maddə həcminin azalması (Haijma S.V. Schizophr Bull 2013, meta-analiz n>8000), mezolimbik dopamin hiperaktivliyi (Howes O.D. Schizophr Bull 2009), 60–80% irsilik (Sullivan P.F. 2003). D2 reseptor antaqonist antipsixotiklərin effektinin dozaya proporsional olması farmakoloji mexanizmin spesifikliyini sübut edir. «Ələ keçirilmə» konsepsiyası neyrobioloji səviyyədə yoxlanıla bilən deyil (müqayisə: Howes O.D., Kapur S. 2009) və falsifikasiyaya açıq deyil.

Sübut: WHO mhGAP Intervention Guide v2.0 — şizofreniya tibbi xəstəlik kimi tanınır. APA Resource Document on Religious/Spiritual Commitments (2018): dini praktika müalicəni *tamamlaya* bilər, lakin *əvəz edə bilməz*.

Real klinik addım: antipsixotikin başlanması təxirə salınmamalıdır. Ailənin dini-mədəni inanclarına hörmət terapevtik ittifaqı qoruyur — ekzorsizm rituallarının antipsixotik müalicəni əvəzləməsinə yol verilməsi müalicənin gecikməsi ilə pis proqnoza səbəb olur (Marshall M. və b. Arch Gen Psychiatry 2005 — DUP > 1 il pis proqnoz markeridir).

Mif 2: «Şizofreniya — pis tərbiyə və ya „soyuq ana“ nəticəsidir»

Niyə yayılıb: 1940–1960-cı illərdə psixoanalitik məktəbin təsiri (Fromm-Reichmann F. — «şizofrenogen ana» konsepsiyası); ailəni günahlandıran model klinik praktikada uzun zaman dominant qalıb.

Klinik və bioloji məntiq: İrsilik payı 60–80% təşkil edir; bioloji ailədə böyüməyən övladlığa götürülmüş uşaqlarda risk bioloji valideynlərin diaqnozu ilə əlaqəlidir, övladlığa götürən ailənin xüsusiyyətləri ilə deyil (Heston L.L. Br J Psychiatry 1966; Tienari P. və b. Br J Psychiatry 2004 — Finlandiya adoptiv tədqiqatı). Yüksək emosional ekspressiya (EE) olan ailədə residiv riski artır, lakin bu — ilkin etiologiya deyil, gediş modulatorudur.

Sübut: APA, AAP, NICE — «şizofrenogen ana» konsepsiyası elmi cəmiyyət tərəfindən tərk edilmişdir.

Real klinik addım: ailə müdaxiləsi (bax «Müalicə metodikaları») — günahlandırma əsasında deyil, psixoedukasiya və ünsiyyət təlimi əsasında qurulur.

Mif 3: «Şizofreniya = ikili (split) şəxsiyyət»

Niyə yayılıb: Etimologiya yanılması — «şizo» (yarılmış) + «frenia» (ağıl) sözünün «şəxsiyyət yarılması» kimi səhv tərcüməsi; kütləvi mədəniyyət (film, ədəbiyyat) yanlış obrazları gücləndirir.

Klinik və bioloji məntiq: «Bleuler 1911» termini ağılın daxili tutarlılığının pozulmasını (assosiasiyaların yarılması) ifadə edirdi, ayrı şəxsiyyətlərin mövcudluğunu deyil. «İkiqat şəxsiyyət» — fərqli bir pozuntudur: dissosiativ identifikasiya pozuntusu (6B64), tamamilə fərqli etiologiya (uşaqlıq travması) və klinik təzahürlər.

Sübut: WHO XBT-11 — şizofreniya (6A20) və DİP (6B64) ayrıca pozuntular kimi kodlanır.

Mif 4: «Şizofreniyalı insanlar təhlükəlidir və aqressivdir»

Niyə yayılıb: Kütləvi media zorakı hadisələrdə psixoz keçmişini xüsusi vurğulayır — media belə halları geniş işıqlandırır, lakin baza nisbətini təqdim etmir.

Klinik və bioloji məntiq: Şizofreniyalı insanlar zorakılığın qurbanı olmaq ehtimalı daha yüksəkdir (Maniglio R. Acta Psychiatr Scand 2009 sistemli icmal — cinayət növündən asılı olaraq viktimizasiya nisbəti 2,3–140 dəfə arasında). Zorakılıq riski yalnız spesifik dar kontekstdə artır: müalicə almayan kəskin paranoid sayıqlama + paralel maddə istifadəsi (Fazel S. və b. PLoS Med 2009 meta-analiz). Müalicə alan stabil pasiyentlərdə əhali ilə müqayisədə fərq minimaldır.

Sübut: Şizofreniyaya aid şizofreniya diaqnozu olan şəxslərin törətdiyi zorakılıq cəmiyyətdə qeydə alınan zorakılığın 5%-dən azını təşkil edir (Fazel S. Br J Psychiatry 2014).

Real klinik addım: damğalama psixososial bərpaya əngəldir; ailə və ictimaiyyət üçün psixoedukasiya kritik vacibdir.

10.2 Zərərli «müalicə» üsulları

Mif 5: «Ekzorsizm və ya dini ritual antipsixotiki əvəzləyə bilər»

Niyə yayılıb: Antipsixotiklərin yan təsirlərindən qorxu; dini icmalar daxilində sosial dəstəyin daha əlçatan olması; psixiatrik xidmətin stigması.

Risk: Müalicəsiz psixoz dövrünün (MDP) hər ay uzanması ilə pasiyentin uzunmüddətli funksional proqnozu pisləşir (Marshall M. və b. Arch Gen Psychiatry 2005, n=3700 meta-analiz). DUP > 1 il olan pasiyentlərdə remissiya dərəcəsi əhəmiyyətli azalır. Müalicəsiz kəskin epizodda intihar riski yüksəkdir.

Sübut: NICE CG178, WHO mhGAP — antipsixotik müalicə təxirə salınmamalı; dini-mədəni dəstək paralel tətbiq oluna bilər.

Mif 6: «İnsulin koma terapiyası» və «lobotomiya» — köhnə müalicələr indi də xəstəxanalarda gizli tətbiq olunur

Reallıq: İnsulin koma terapiyası (Sakel 1933) və prefrontal lobotomiya (Moniz 1936, Freeman 1945) 1950-ci illərdə kütləvi tətbiq olunurdu, lakin antipsixotiklərin (xlorpromazin 1952) meydana gəlməsi ilə müqayisəli effekt sübutu olmaması və ağır yan təsirləri səbəbilə tərk edilmişdir. Müasir klinik praktikada bu üsullar yoxdur. EKT (elektrokonvulsiv terapiya) isə fərqlidir — sübutlu, müasir göstərişlərdə şizofreniya katatonik xüsusiyyətlərlə və ya refrakter hallarda yer alır (NICE TA59).

10.3 Səmərəsiz və ya əsas müalicəni təxirə salan üsullar

Mif 7: «Vitamin B3 (niasin) mega-dozaları şizofreniyanı müalicə edir» (ortomolekulyar psixiatriya)

Niyə yayılıb: Hoffer və Osmond 1950-ci illərdə tək halların təsvirinə əsaslanaraq niasin mega-doza nəzəriyyəsini irəli sürmüşlər. Alternativ tibb cərəyanı bu yanaşmanı dəstəkləməyə davam edir.

Sübut: APA Task Force (Lipton M.A. və b. 1973) və sonrakı RKİ-lər — vitamin B3 və ya digər vitamin mega-dozaları şizofreniya simptomlarına təsir göstərmir. Niasin mega-dozası qaraciyər zədəsi və hiperurikemiya yarada bilər.

Mif 8: «Kannabis (xüsusilə CBD) şizofreniyanı sağaldır»

Niyə yayılıb: CBD-nin antipsixotik təsiri haqqında ilkin tədqiqatların kütləvi mediada şişirdilmiş təqdimatı; tibbi kannabis məhsullarının təbliği.

Reallıq: tetrahidrokannabinol (THC) — kannabisin əsas psixoaktiv komponenti psixoz riskini 2–3 dəfə artırır (Marconi A. və b. Schizophr Bull 2016 meta-analiz). CBD haqqında ilkin RKİ-lər (McGuire P. və b. Am J Psychiatry 2018) kiçik effekt göstərmişdir, lakin sübut bazası standart antipsixotikləri əvəzləmək üçün kafi deyil.

Sübut: NICE CG178, APA 2021 — CBD şizofreniya müalicəsində standart tövsiyə deyil; THC tərkibli kannabis əks-göstərişdir.

Mif 9: «Antipsixotiklər beyni zədələyir, „zombi“ edir, ömürlük istifadə zərərlidir»

Niyə yayılıb: Erkən tipik antipsixotiklərin ağır EKPS yan təsirləri; pasiyent təcrübələri sosial şəbəkələrdə paylaşılır.

Bioloji məntiq: Antipsixotik istifadəsi ilə bağlı struktur dəyişikliklər mövcuddur (Ho B.C. və b. Arch Gen Psychiatry 2011), lakin müqayisə edilməlidir ki, müalicəsiz şizofreniyanın özü daha sürətli kortikal həcm azalmasına səbəb olur (Cahn W. və b. Arch Gen Psychiatry 2002). Antipsixotik kəsmə residiv riskini kəskin artırır — bir ildə 27% əvəzinə 64% (Leucht S. Lancet 2012), residiv özü neyrotoksik təsir göstərir.

Sübut: Tiihonen J. və b. (Lancet 2009, JAMA Psychiatry 2018) Finlandiya reyestr tədqiqatları n>60 000: davamlı antipsixotik istifadə mortalitet və xəstəxana yatımını azaldır.

Real klinik addım: yan təsir profilinə görə preparat seçimi, doza titrasiyası və pasiyent şikayətlərinə cavab — pasiyentlə davamlı dialoq daxilində idarə olunur.

Mif 10: «Şizofreniya müalicə olunmur, ömürlük xəstədir, bərpa mümkün deyil»

Reallıq: Hegarty 1/3 prinsipi (Am J Psychiatry 1994) — pasiyentlərin təxminən 1/3-də yaxşı funksional bərpa müşahidə olunur; xüsusilə Erkən Müdaxilə Xidmətləri (EIP) ilə bu nisbət artır (Kane J.M. və b. Am J Psychiatry 2016 — RAISE RKİ). «Klinik bərpa» və «şəxsi bərpa» (şəxsi bərpa modeli) fərqlənir — pasiyent simptomu tam itirməsə də mənalı həyat qura bilər.

Real klinik addım: proqnoz fərdidir; erkən müdaxilə, müalicəyə riayət, ailə dəstəyi və psixososial reabilitasiya bərpa şanslarını əhəmiyyətli artırır.

Mif 11: «Antipsixotikin əvəzinə akupunktura, homeopatiya, valerian effektivdir»

Sübut: Cochrane icmalları (Rathbone J. Cochrane 2007 — akupunktura; Ernst E. icmalları — homeopatiya) — şizofreniyada effekt sübutu yoxdur. Köməkçi (komplementar) üsullar əlavə müalicə kimi (stress idarəsi, yuxu hijyeni) tətbiq oluna bilər, lakin antipsixotiki əvəzləmir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstələnmə və Ölüm Statistikasının Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11, 2024 versiyası). 6A20 Şizofreniya. icd.who.int
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, Beşinci Nəşr, Mətn Yenilənməsi (DSM-5-TR). Vaşinqton, Kolumbiya Dairəsi: Amerika Psixiatriya Assosiasiyası Nəşriyyatı; 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik Təlimat 178. Yetkinlərdə psixoz və şizofreniya: profilaktika (qarşısının alınması) və idarəetmə. 2014, 2019-cu il yenilənməsi. nice.org.uk/guidance/cg178
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Şizofreniyalı Xəstələrin Müalicəsi üzrə Təcrübə Rəhbərliyi, 3-cü nəşr. 2021.
5. Hasan A., Falkai P., Vobrok T. və b. Şizofreniyanın bioloji müalicəsi üzrə WFSBP Rəhbərliyi. «Dünya Bioloji Psixiatriya Jurnalı» (World J Biol Psychiatry). 2012;13(5):318–378; 2015-ci il yenilənməsi.
6. Teylor D.M., Barns T.R.E., Yanq A.H. Psixiatriyada Modsli Təyinat Rəhbərliyi, 14-cü nəşr. Uayli-Blekvell; 2021.

7. Sallivan P.F., Kendler K.S., Nil M.K. Şizofreniya mürəkkəb əlamət kimi. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2003;60(12):1187–1192.
8. Trubetskoy V., Pardinyas A.F., Qi T. və b. Genom lokuslarının xəritələnməsi şizofreniyada genləri və sinaptik biologiyanı göstərir. «Nature» (Nature). 2022;604(7906):502–508.
9. Hauz O.D., Kapur S. Şizofreniyanın dopamin hipotezi: III versiya. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2009;35(3):549–562.
10. Hayma S.V., Van Haren N., Kan V. və b. Şizofreniyada beyin həcmləri: meta-analiz. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2013;39(5):1129–1138.
11. Saha S., Çant D., Velham C., MakQrat C. Şizofreniyanın yayılmasının sistematik icmalı. «PLoS Təbabəti» (PLoS Med). 2005;2(5):e141.
12. Markoni A., Di Forti M., Lyuis K.M. və b. Kannabis istifadəsi və psixoz riski. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2016;42(5):1262–1269.
13. Hor K., Teylor M. İntihar və şizofreniya. «Psixofarmakologiya Jurnalı» (J Psychopharmacol). 2010;24(11 Suppl 4):81–90.
14. Loyxt S., Tardi M., Komossa K. və b. Şizofreniyada relapsın profilaktikası üçün antipsixotik dərmanlar və plasebo. «Lancet» (Lancet). 2012;379(9831):2063–2071.
15. Keyn C., Honigfeld Q., Singer C., Meltzer H. Müalicəyə davamlı şizofreniyada klozapin. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 1988;45(9):789–796.
16. Siskind D., MakKartni L., Qoldşlager R., Kiseli S. Müalicəyə davamlı şizofreniyada klozapin birinci və ikinci nəsil antipsixotiklərə qarşı. «Britaniya Psixiatriya Jurnalı» (Br J Psychiatry). 2016;209(5):385–392.
17. Vayks T., Stil K., Everitt B., Tarrier N. Şizofreniya üçün koqnitiv davranış terapiyası: effekt ölçüləri, klinik modellər və metodoloji ciddilik. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2008;34(3):523–537.
18. Faroa F., Mari C., Ratboun C., Vonq V. Şizofreniya üçün ailə müdaxiləsi. «Kokreyn Sistematik İcmallar Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2010; (12):CD000088.
19. Dreyk R.E., Bond Q.R., Qoldman H.H. və b. Fərdi yerləşdirmə və dəstək xidmətləri ağır ruhi xəstəlikləri olan insanların məşğulluğunu artırır. «Səhiyyə Məsələləri» (Health Aff (Millwood)). 2016;35(6):1098–1105.
20. Keyn C.M., Robinson D.G., Şuler N.R. və b. İlk epizod psixozunda kompleks və adi icma xidmətinin müqayisəsi (RAISE). «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2016;173(4):362–372.

21. Tiihonen C., Mittendorfer-Rutz E., Macak M. və b. Şizofreniyalı 29 823 xəstədən ibarət milli kohortda antipsixotik müalicənin real effektivliyi. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2017;74(7):686–693.
22. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. «Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə Klinik Protokol». Bakı; 2009.
23. Fromm-Reyxmann F. Şizofreniyalı xəstələrin psixoanalitik psixoterapiya ilə müalicəsinin inkişafına dair qeydlər. «Psixiatriya» (Psychiatry). 1948;11(3):263–273.
24. Ernst E. Homeopatiya üzrə sistematik icmalların sistematik icmalı. «Britaniya Klinik Farmakologiya Jurnalı» (Br J Clin Pharmacol). 2002;54(6):577–582.
25. Huybrexts K.F., Ernandes-Dias S., Patorno E. və b. Hamiləlikdə antipsixotiklərin istifadəsi və anadangəlmə qüsurlar riski. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2016;73(9):938–946.
26. Aleman A., Kahn R.S., Selten C.P. Şizofreniya riskində cins fərqləri: meta-analiz nəticələri. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2003;60(6):565–571.
27. Olfson M., Gerhard T., Huang C. və b. ABŞ-da şizofreniyalı böyüklərdə vaxtından əvvəl ölüm halları. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2015;72(12):1172–1181.

XBT-11 **6A21**	**6A21 ŞİZOAFFEKTİV POZUNTU** **Schizoaffective disorder**
XBT-10 F25	Şizoaffektiv pozuntu
DSM-5-TR F25.0–F25.1	Şizoaffektiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Şizoaffektiv pozuntu (ing. XBT-11: 6A21 Schizoaffective Disorder; DSM-5-TR: F25.0, F25.1) — psixotik simptomlar (sayıqlama, hallüsinasiya, dezorqanizə nitq) və affektiv epizod (manik və ya depressiv) eyni klinik epizod ərzində birgə müşahidə edilən, lakin əlavə olaraq affektiv epizoddan kənar dövrlərdə də psixotik simptomların davam etdiyi ilkin psixotik pozuntudur.

Pozuntu psixotik pozuntular spektrində şizofreniya və affektiv pozuntu arasında orta vəziyyət tutur — bir tərəfdən «psixotik xüsusiyyətlərlə affektiv pozuntudan», digər tərəfdən «şizofreniyadan» fərqlənir (psixotik simptomların affektiv epizod kontekstindən asılı olmadan davam etməsi).

DSM-5-TR-də iki tip göstəricisi mövcuddur:: bipolyar tip (manik və ya depressiv epizodlar) və depressiv tip (yalnız depressiv epizodlar). XBT-11-də alt-spesifikasiyalar paralel — affektiv epizod tipinə görə.

2. Tarixçə

- Kasanin J. (1933) — «kəskin şizoaffektiv psixozlar» (acute schizoaffective psychoses) terminini ilk dəfə təqdim etmişdir; sürətli başlanğıc və yaxşı proqnoz vurğulanırdı.
- 1970-ci illər — Carpenter W., Strauss J., Bartko J. — şizofreniya və affektiv pozuntudan ayrı klinik vahid kimi tədqiq edilmişdir.
- DSM-III (1980) — DSM-III-də (1980) şizoaffektiv pozuntu «qarışıq» kateqoriya kimi təsnif edilmişdir.
- DSM-IV (1994), DSM-5 (2013) — DSM-IV (1994) və DSM-5 (2013)-də diaqnostik meyarlar dəqiqləşdirilmişdir; bipolyar/depressiv tip ayrı-seçkisi saxlanılmışdır.
- XBT-11 (2019) — 6A21 şizoaffektiv pozuntu vahid kateqoriya kimi təqdim edilmişdir; bipolyar/depressiv tip yalnız DSM-5-TR-də göstərilir.
- Diaqnostik etibarlılıq müzakirəsi — Malhi G.S. və b. Aust N Z J Psychiatry 2008, Lake C.R., Hurwitz N. Curr Psychiatry Rep 2007: şizoaffektiv pozuntunun şizofreniya və affektiv pozuntudan ayrı bir vahid olub-olmaması mübahisəlidir; bəzi tədqiqatçılar onu spektral konsepsiya daxilində görürlər.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: təxminən 0,3% (Perälä J. və b. Arch Gen Psychiatry 2007 Finlandiya əhalisi üzrə tədqiqat, n=8000).
- Şizofreniyanın yayılma göstəricilərinin (0,3–0,7%) aşağı həddinə uyğun gəlir.
- Cins: qadınlarda daha çox rast gəlinir (1,2–1,5:1); depressiv tip qadınlarda üstünlük təşkil edir.
- Başlanğıc yaşı: orta 20–30 yaş; bipolyar tip daha gənc yaşda, depressiv tip isə daha gec başlayır.
- Komorbidlik: maddə istifadəsi pozuntusu təxminən 40%, təşviş pozuntuları təxminən 30%, intihar riski şizofreniya ilə müqayisəli (təxminən 5%).

- Ölüm göstəricisi: ümumi ölüm halları əhali ilə müqayisədə 2–3 dəfə yüksəkdir.

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

- Şizofreniya və bipolyar pozuntu ilə genetik üst-üstə düşmə yüksəkdir: genom üzrə assosiasiya tədqiqatları (GWAS) (ing. Cross-Disorder Group of Psychiatric Genomics Consortium. Lancet 2013, Cell 2019) — şizofreniya, bipolyar və şizoaffektiv pozuntu arasında geniş genetik korrelyasiya.
- Ailə tədqiqatları — şizoaffektiv pasiyentlərin qohumlarında həm şizofreniya, həm də əhval pozuntularının riski artmışdır (Maier W. və b. Arch Gen Psychiatry 1993).

4.2 Neyrobioloji

- Şizofreniya ilə üst-üstə düşən modellər — dopamin disregulasiyası, kortikal həcm dəyişiklikləri, NMDA reseptorları vasitəsilə qlutamat ötürülməsinin pozulması.
- Affektiv komponentlə əlaqəli — limbik və monoaminergik (serotonin, noradrenalin) sistemlərin disfunksiyası ilə əlaqəlidir.
- Şizofreniyaya nisbətən daha az ifadə olunmuş struktur dəyişiklikləri və daha yaxşı koqnitiv profil müşahidə olunur (Heckers S. Curr Psychiatry Rep 2009 icmal).

4.3 Mühit risk amilləri

- Şizofreniya ilə üst-üstə düşür — obstetrik fəsadlar, prenatal infeksiyalar, kanabis istifadəsi yeniyetməlikdə, miqrasiya, şəhər mühiti
- Erkən travma və psixososial stress affektiv komponentin tətikləyicisi kimi rol oynaya bilər.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Əsas modellər

- Manik epizod fonunda psixoz — əzəmət sayıqlamaları, eqo-sintonik əzəmət sayıqlamaları və hallüsinasiyalar, sürətli düşüncə axını, təzyiqli nitq və davranış.
- Depressiv epizod fonunda psixoz — günah sayıqlamaları, nihilistik sayıqlamalar, eşitmə hallüsinasiyaları (mühakimə edən, ittiham edən səslər), aşağı motivasiya.

- Affektiv epizoddan kənar dövrlərdə — pozitiv (sayıqlama, hallüsinasiya) və/və ya neqativ (affektiv yastılıq, avoliya (avolition)) simptomlar davam edir — bu meyar pozuntunu «psixotik xüsusiyyətlərlə affektiv pozuntudan» ayırır.

5.2 Gediş və mərhələlər

- Gediş tipik olaraq episodikdir: affektiv epizodlar və psixotik komponentlər müxtəlif şiddətdə təzahür edir.
- Şizofreniyadan daha yaxşı funksional bərpa, lakin əhəmiyyətli sosial və peşəkar fəaliyyətdə pozulma mövcuddur.
- bipolyar tipdə manik və depressiv dövrlər, depressiv tipdə isə davamlı depressiv komponentlər müşahidə edilir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11 konsensus nöqtələri)

A. Kəsilməz xəstəlik dövrü ərzində, şizofreniya A meyarına uyğun şizofreniyanın A meyarına uyğun simptomlar (≥1 ay) ilə birlikdə əsas affektiv epizod (manik və ya depressiv) müşahidə edilməlidir.

B. Sayıqlama və ya hallüsinasiyalar ≥ 2 həftə ərzində əsas affektiv epizod olmadan mövcud olmuşdur (xəstəliyin ömürlük gedişində).

C. Əsas affektiv epizoda uyğun simptomlar xəstəliyin ümumi müddətinin əksəriyyətində mövcud olmalıdır (aktiv və residual hissələrin ümumi müddəti nəzərə alınmaqla).

D. İstisnalar — D. Pozuntu psixoaktiv maddənin (məs. amfetamin) fizioloji təsiri və ya digər tibbi vəziyyət (məs. ensefalit) ilə tamamilə izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR (F25.0–F25.1): meyar B-də 2 həftəlik tələb (DSM-IV-də də 2 həftəlik tələb mövcud idi). Tip kvalifikatorları — bipolyar (manik epizodlar var) və ya depressiv (yalnız depressiv).
- XBT-11 (6A21): şizoaffektiv pozuntu (ing. schizoaffective disorder) — affektiv epizod tipinə görə alt-spesifikasiyalar; dəqiq 2 həftəlik tələb XBT-11-də müəyyən rəqəmlə deyil, «əhəmiyyətli müddət» kimi göstərilir.
- APA Practice Guideline (Schizophrenia 2021): şizoaffektiv pozuntu üçün ayrıca alqoritm yoxdur; şizofreniya və əhval pozuntuları üçün müalicə prinsipləri birləşdirilir.

- WFSBP: şizoaffektiv pozuntunu şizofreniya spektrinə aid pozuntular daxilində qiymətləndirir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + qohumlardan məlumat — affektiv epizodların və psixotik simptomların xronoloji nizamı.
2. Strukturlaşdırılmış müsahibə (SCID-5 və ya MINI).
3. PANSS və BPRS — psixotik simptomların şiddəti; HAM-D və MADRS — depressiyanın şiddəti; YMRS — maniyanın şiddəti.
4. Fiziki və nevroloji müayinə.
5. Sidikdə toksikoloji skrininq (ing. screening) aparılır.
6. Laborator (tam qan, tiroid, qaraciyər, böyrək, qlükoza, HbA1c, lipid, prolaktin).
7. İlk epizodda üzvi səbəblərin istisna edilməsi üçün beyin maqnit-rezonans tomoqrafiyası (MRT) aparılır.
8. Komorbidlik və intihar riski qiymətləndirməsi (C-SSRS).

6.4 Differensial diaqnostika

Pozuntu	**Fərqləndirici əlamətlər**
Şizofreniya (6A20)	Affektiv epizodlar yoxdur və ya minimaldır; mövcud olduqda isə psixozun gedişinin kiçik hissəsini əhatə edir.
Bipolyar I pozuntu, psixotik xüsusiyyətlərlə (6A60)	Psixoz yalnız manik və ya depressiv epizod kontekstində; affektiv epizoddan kənar psixoz yoxdur.
Depressiv pozuntu, psixotik simptomlarla (XBT-11: 6A70/6A71)	Psixoz yalnız depressiv epizod kontekstində.
Maddə induksiyalı psixoz	Maddə istifadəsi ilə zaman bağlılığı; eliminasiyadan sonra remissiya.
İkincili psixotik sindrom (6E61)	Tibbi vəziyyət (ensefalit, lupus, paraneoplastik) ilə əlaqəli.
Sayıqlama pozuntusu (6A24)	Yalnız sayıqlama; affektiv komponent yox.

Pozuntu	Fərqləndirici əlamətlər
Kəskin və keçici psixotik pozuntu (6A23)	(DSM-5-TR: qısa psixotik pozuntu — ən azı 1 gün, 1 aydan az).

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik şkalalar

- Strukturlaşdırılmış müsahibələr: SCID-5, MINI (bax §6.3).
- Psixotik şiddət: PANSS, BPRS.
- Depressiv şiddət: HAM-D (Hamilton), MADRS (Montgomery-Åsberg).
- Manik şiddət: YMRS (ing. Young Mania Rating Scale).
- Funksional: GAF, PSP, SOFAS.
- İntihar riski: C-SSRS.

7.2 Laborator müayinələr

Şizofreniya bölməsindəki kimi (bax: 6A20 Şizofreniya, §7.2):

- Mütləq: tam qan, qaraciyər/böyrək, qlükoza, HbA1c, lipid profili, TSH, B12, folat, toksikoloji skrininq, HIV, sifilis, hamiləlik testi, bazal prolaktin səviyyəsi.
- Seçici: EEQ, anti-NMDA-R antikorları, seruloplazmin (Wilson).
- Litium müalicəsi başlanmazdan əvvəl — kreatinin, TSH, kalsium, EKG.
- Valproat müalicəsi başlanmazdan əvvəl qaraciyər funksiyası və qan analizləri yoxlanılır.

7.3 Cihaz müayinələri

- İlk epizodda beyin MRT aparılır (bax §6.3).
- Antipsixotik və ya litium müalicəsi başlanmazdan əvvəl EKG çəkilir.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (APA 2021, NICE CG178 / CG185, WFSBP konsensusu)

1. Multimodal yanaşma — antipsixotik, əhval stabilizatoru və ya antidepresant ilə psixososial müdaxilənin birləşməsi.
2. Birinci xətt antipsixotikləri — paliperidon, o cümlədən uzunmüddətli təsirli inyeksiya forması (UTİ, LAI) — FDA-nın şizoaffektiv pozuntu üzrə təsdiqi

yalnız aylıq paliperidon palmitat formasına aiddir; risperidon, olanzapin, kvetiapin, aripiprazol — geniş istifadə.

3. Bipolyar tipdə əhval stabilizatoru — litium (İntihar riskinin azaldılması effekti), valproat, lamotrigin (xüsusilə depressiv komponent üstünlük təşkil etdikdə).
4. Depressiv tipdə antidepressant — SSGİ (sertralin, essitalopram) və ya serotonin-norepinefrin geri alım inhibitorları (SNGİ) (venlafaksin); antidepressant tək başına istifadə edilmir, antipsixotik ilə birlikdə.
5. Klozapin müqavimətli hallarda (iki antipsixotikə cavabsızlıq) təyin edilir.
6. EKT ağır katatonik vəziyyətdə, depressiv komponenti olan hallarda, yüksək intihar riski və müqavimətli gediş zamanı effektivdir elektrokonvulsiv terapiya (EKT). (NICE TA59, Elektrokonvulsiv terapiyanın tətbiqi üzrə təlimat).
7. Psixososial müdaxilə — KDTp (psixoz üçün KDT), ailə psixoedukasiyası, dəstəkləyici psixoterapiya, Fərdi Yerləşdirmə və Dəstək (FYD, IPS) proqramı.
8. Müalicəyə riayət və residivin profilaktikası — LAI (paliperidon palmitat, aripiprazol LAI) seçilmiş pasiyentlərdə.
9. Komorbidlik müalicəsi — maddə istifadəsi pozuntusunun paralel müalicə proqramı çərçivəsində idarə edilməsi, narahatlıq, somatik xəstəliklər.
10. Metabolik göstəricilərin və yan təsirlərin izlənməsi — antipsixotiklərdə standart.

8.2 Farmakoterapiya

Sinif	**Preparat / nümunələr**	**Göstəriş**
Atipik antipsixotik	Paliperidon (FDA təsdiqi), risperidon, olanzapin, kvetiapin, aripiprazol	Pozitiv və neqativ simptomlar; əsas müalicə kimi tətbiq edilir.
Atipik antipsixotik LAI	Paliperidon palmitat (aylıq/3 aylıq/6 aylıq), aripiprazol LAI	Adhesiya problemində və ya pasiyent seçimi ilə.
Əhval stabilizatoru	Litium, valproat, karbamazepin, lamotrigin	bipolyar tipdə; litium intihar riskini azaldır.
Antidepressant	SSGİ (sertralin, esitalopram), SNGİ (venlafaksin)	Depressiv tipdə; tək başına deyil, antipsixotik ilə birlikdə.

Sinif	Preparat / nümunələr	Göstəriş
Refrakter	Klozapin	İki antipsixotikə cavabsızlıq.
Adjunkt	Benzodiazepin (lorazepam) qısamüddətli	Kəskin agitasiya və ya katatoniyada.

8.3 EKT göstərişləri

- Katatonik xüsusiyyətlər.
- Ağır psixotik depressiv epizod.
- İntihar riski və ya qida və maye qəbulundan imtina.
- Hamiləlik dövründə ağır hallarda, risk-fayda nisbəti qiymətləndirilməklə tətbiq edilir.
- Farmakoterapiyaya cavabsızlıq.

8.4 Müalicə metodikaları

1. Psixoz üçün Koqnitiv-Davranış Terapiyası (ing. cognitive behavioural therapy for psychosis, KDTp) — Şizofreniyada olduğu kimi uyğunlaşdırılır; bax «Müalicə metodikaları», bax: 6A20 Şizofreniya bölməsi və NICE CG178 §1.3.7.1.
2. Ailə psixoedukasiyası və müdaxiləsi (ing. Family Psychoeducation) — Yüksək emosional ifadə (EE) olan ailələrdə residiv riskini azaldır. NICE CG178 §1.3.7.2; Pharoah Cochrane 2010.
3. Fərdi Yerləşdirmə və Dəstək (ing. individual placement and support, FYD) — Dəstəkli işə cəlb olunma «əvvəlcə yerləşdir, sonra hazırla» (place-then-train) prinsipi ilə. Drake R.E. və b. Health Aff (Millwood) 2016.
4. Litium — Bipolyar tip şizoaffektiv pozuntuda əhval stabilizasiyası və intihar profilaktikası; bazal göstəricilər: kreatinin, TSH, kalsium səviyyəsi və EKG; terapevtik səviyyə 0,6–1,0 mmol/L; Cipriani A. və b. BMJ 2013 — intiharı azaldır.
5. Lamotrigin — bipolyar depressiv epizodun profilaktikasında istifadə edilir; başlanğıc titrasiyası tədricən aparılır (Stivens-Conson sindromu riski).
6. Paliperidon Palmitat uzunmüddətli təsirli inyeksiya (ing. UTİ; long-acting injectable, LAI) — Aylıq, 3 aylıq və 6 aylıq formalar. FDA-nın şizoaffektiv pozuntu göstərişi yalnız aylıq formadadır (ing. Invega Sustenna); 3 aylıq (Trinza) və 6 aylıq (Hafyera) yalnız şizofreniya üçün təsdiqlidir. Müalicəyə riayət problemi olan pasiyentlərdə və residivin profilaktikasında üstünlük təşkil edir.

7. Elektrokonvulsiv Terapiya (ing. Electroconvulsive Therapy, EKT) — Katatonik xüsusiyyətlər, ağır psixotik depressiya, İntihar riski və ya refrakter hallarda effektiv. NICE TA59 psixotik depressiya və katatoniya zamanı EKT-ni tövsiyə edir. UK EKT Review Group Lancet 2003 meta-analiz — ağır depressiyada EKT farmakoterapiyadan üstündür.
8. PANSS, HAM-D və YMRS psixotik, depressiv və manik komponentlərin ayrıca standartlaşdırılmış qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir.

8.5 Mənbələr arasında fərqlər

- APA 2021 (Schizophrenia): şizoaffektiv pozuntunun müalicə alqoritmi şizofreniya ilə paraleldir; əhval komponentinə görə əlavə müdaxilə.
- NICE CG178 (Psixoz) və CG185 (Bipolyar pozuntu): hər ikisi şizoaffektiv pozuntuya tətbiq olunur — psixotik komponent CG178, affektiv komponent CG185.
- WFSBP: şizoaffektiv pozuntuda WFSBP şizoaffektiv pozuntunu şizofreniya spektri daxilində qiymətləndirir və antipsixotik müalicəni şizofreniya prinsipləri üzrə tövsiyə edir.
- CANMAT / ISBD 2018: bipolyar tip şizoaffektiv pozuntu — bipolyar pozuntunun müalicə alqoritmlərinə uyğun aparılır.

9. Proqnoz

9.1 Yaxşı proqnoz amilləri

- Bipolyar tip depressiv tipdən daha yaxşı proqnoza malikdir.
- Sürətli başlanğıc və aydın affektiv komponent əlverişli proqnoz göstəriciləridir.
- Premorbid yaxşı funksional səviyyə.
- Erkən müdaxilə və müalicəyə riayət proqnozu yaxşılaşdırır.
- Sosial dəstək.
- Komorbid maddə istifadəsinin müalicəsi və nəzarəti.

Pis proqnoz amilləri

- Depressiv tip.
- Tədricən başlanğıc.
- Neqativ simptomların üstünlüyü.
- Komorbid maddə istifadəsi.
- tarixçəsində intihar cəhdi olması.

- Müalicəyə riayətsizlik.

İzləmə hədəfləri

- Psixotik və affektiv simptomların ayrı-ayrı izlənməsi (PANSS, HAM-D, YMRS).
- İntihar riski xüsusilə depressiv epizodlarda və xəstəliyin ilk illərində davamlı qiymətləndirilir.
- Metabolik göstəricilərin izlənməsi.
- Litium qəbul edənlərdə TSH, kreatinin və kalsium səviyyəsi 6 ayda bir dəfə yoxlanılır.
- Funksional bərpa, məşğulluq və sosial əlaqələr izlənilməlidir.
- Ailə dəstəyi və ailə psixoedukasiyası.

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya və konseptual mifləri

Mif 1: «Şizoaffektiv pozuntu yüngül şizofreniyadır»

Niyə yayılmışdır: şizoaffektiv pasiyentlərin orta hesabla şizofreniya pasiyentlərindən daha yaxşı funksional bərpa göstərməsi tez-tez yanlış şərh edilir.

Klinik və bioloji məntiq: Şizoaffektiv pozuntu klinik təzahürlər baxımından şizofreniya ilə üst-üstə düşür (psixotik simptomlar affektiv epizoddan kənar), lakin əhval pozuntusu komponenti əlavə olunur. «Yüngül forma» deyil — ayrı diaqnostik vahiddir. Bəzi pasiyentlər ağır gediş göstərir.

Sübut: Heckers S. Curr Psychiatry Rep 2009 — şizoaffektiv pozuntu şizofreniya ilə neyrobioloji cəhətdən üst-üstə düşür, lakin əhəmiyyətli klinik fərqlərə malikdir; «şizofreniya yüngül forması» konsepsiyası dəstəklənmir.

Mif 2: «Şizoaffektiv pozuntu yalnız iki ayrı diaqnozun (şizofreniya + bipolyar) qarışıqlığıdır»

Sübut: Cross-Disorder Psychiatric Genomics Consortium 2013 — şizofreniya, bipolyar və şizoaffektiv arasında geniş genetik üst-üstə düşmə. Bu, diaqnostik vahidlərin spektrum daxilində yerləşdiyini göstərir — şizoaffektiv ayrıca diaqnostik vahid kimi saxlanılır, çünki uzunmüddətli izləmədə fərqli gediş və müalicəyə fərqli cavab göstərir.

Mif 3: «Şizoaffektiv pozuntu uydurma diaqnozdur, etibarlılığı yoxdur»

Niyə yayılıb: akademik müzakirə (Malhi 2008, Leyk və Hurvits 2007) — bəzi araşdırmaçılar diaqnozun praktik dəyəri haqqında sual qaldırırlar.

Klinik məntiq: diaqnozun validliyi mübahisəlidir, lakin klinik faydalılığı (müalicə qərarı və proqnoz üçün işlək çərçivə) saxlanılır. DSM-5-TR və XBT-11 hər ikisi diaqnostik vahid kimi saxlayır. Klinik praktikada diaqnoz standart meyarlara əsaslanaraq qoyulmalıdır. — fərqi başqa pozuntulardan dəqiq müəyyən etmək vacibdir, çünki müalicə yanaşması fərqlidir.

10.2 Yanlış müalicə yanaşmaları

Mif 4: «Antidepressant şizoaffektiv pozuntuda tək başına istifadə edilə bilər»

Klinik məntiq və sübut: antidepresantların tək başına istifadəsi tövsiyə edilmir — depressiv tipdə manik epizoda keçid, psixotik gedişdə isə psixozun şiddətlənməsi riski. NICE CG185, CANMAT 2018 — antipsixotik ilə birlikdə.

Mif 5: «Litium şizoaffektiv pozuntuda təsirsizdir»

Sübut: Cipriani A. və b. BMJ 2013 meta-analiz — litium bipolyar spektrində (şizoaffektiv pozuntunun bipolyar tipi daxil olmaqla) İntihar riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bipolyar tip şizoaffektiv pozuntuda litium effektiv əhval stabilizatorudur.

Mif 6: «Klozapin yalnız refrakter şizofreniya üçündür, şizoaffektiv pozuntu üçün deyil»

Sübut: klozapinin şizoaffektiv pozuntuda iki antipsixotikə cavabsızlıq halında istifadəsi qabul edilmiş klinik praktikadır; İntihar riskinin azaldılması effekti şizoaffektiv pasiyentlərə də yayılır (Meltzer H.Y. və b. Arch Gen Psychiatry 2003 InterSePT tədqiqatı).

10.3 Səmərəsiz və ya zərərli yanaşmalar

Mif 7: «Ekzorsizm, ruhani praktika və ya dini ritual şizoaffektiv pozuntunu sağaldır»

Sübut: şizofreniyadakı kimi — psixotik simptomlar neyrobioloji əsaslıdır; ekzorsizm antipsixotik müalicəni təxirə salır, klinik nəticələri pisləşdirir (müalicəsiz psixoz müddəti (DUP) pis proqnoz göstəricisidir (Marşall M. və b. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):975–983)).

Mif 8: «Kannabis əhval stabilizatoru kimi şizoaffektiv pozuntunu sağaldır»

Sübut: kannabis psixoz riskini 2–3 dəfə artırır (Marconi A. və b. Schizophr Bull 2016); şizoaffektiv pasiyentlərdə əks-göstəriş hesab olunur — simptomları gücləndirir.

Mif 9: «Yüksək dozalı vitaminlər və bitki preparatları (dazıotu (St John's wort), valerian) farmakoterapiyanı əvəzləyir»

Sübut: sistemli icmallarda təsiri sübut olunmamışdır; dazıotu (St John's wort) sitokrom P450 induksiyası ilə antipsixotiklərin və əhval stabilizatorlarının konsentrasiyasını azaldır.

Mif 10: «Komplementar müdaxilələr (akupunktura, homeopatiya, kraniosakral) antipsixotikləri əvəz edir»

Sübut: heç birinin şizoaffektiv pozuntu üçün təsiri sübut edilməmişdir.

Mif 11: «Aktiv depressiv epizoddan kənar farmakoterapiya tələb olunmur»

Sübut: şizoaffektiv pozuntu meyarına görə psixotik simptomlar affektiv epizoddan kənar dövrlərdə də mövcuddur — uzunmüddətli davamedici antipsixotik müalicə tövsiyə edilir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və xəstələnmə statistikası üzrə Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A21 Şizoaffektiv pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). Vaşinqton: APA Nəşriyyatı; 2022.
3. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Şizofreniyalı xəstələrin müalicəsi üzrə klinik rəhbərlik, 3-cü nəşr. 2021.
4. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik Təlimat 178: Böyüklərdə psixoz və şizofreniya — profilaktika və idarəetmə. 2014, 2019-cu il yenilənməsi.
5. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik Təlimat 185: Bipolyar pozuntu — qiymətləndirmə və idarəetmə. 2014, 2020-ci il yenilənməsi.
6. Yatham L.N., Kennedy S.H., Parikh S.V. və b. Bipolyar pozuntulu xəstələrin idarə edilməsi üzrə Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) və Beynəlxalq Bipolyar Pozuntular Cəmiyyətinin (ISBD) 2018 təlimatları. «Bipolyar Pozuntular» (Bipolar Disord). 2018;20(2):97–170.

7. Perälə C., Suvisaari C., Saarni S.I. və b. Ümumi əhalidə psixotik və bipolyar I pozuntuların həyat boyu yayılması. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2007;64(1):19–28.
8. Psixiatrik Genomika Konsorsiumunun Pozuntulararası İşçi Qrupu. Beş əsas psixiatrik pozuntuya ümumi təsir göstərən risk lokuslarının müəyyənləşdirilməsi: genom boyu analiz. «Lancet». 2013;381(9875):1371–1379.
9. Hekers S. Şizoaffektiv pozuntu faydalı diaqnozdurmu? «Müasir Psixiatriya Hesabatları» (Curr Psychiatry Rep). 2009;11(4):332–337.
10. Malhi G.S., Green M., Fagiolini A., Peselow E.D., Kumari V. Şizoaffektiv pozuntu: diaqnostik məsələlər və gələcək tövsiyələr. «Bipolyar Pozuntular» (Bipolar Disord). 2008;10(1 hissə 2):215–230.
11. Lake C.R., Hurvitz N. Şizoaffektiv pozuntu şizofreniya və bipolyar pozuntuları vahid xəstəlik kimi birləşdirir — şizoaffektiv pozuntu yoxdur. «Psixiatriyada Müasir Fikirlər» (Curr Opin Psychiatry). 2007;20(4):365–379.
12. Çipriani A., Hawton K., Stokton S., Geddes C.R. Əhval pozuntularında intiharın profilaktikasında litium: yenilənmiş sistematik icmal və meta-analiz. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2013;346:f3646.
13. Meltzer H.Y., Alphs L., Green A.I. və b. Şizofreniyada intihar davranışının müalicəsində klozapin: Beynəlxalq İntiharın Qarşısının Alınması Tədqiqatı (InterSePT). «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2003;60(1):82–91.
14. Marshall M., Lewis S., Lokvud A. və b. Müalicə olunmamış psixozun müddəti ilə nəticə arasında əlaqə. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(9):975–983.
15. Böyük Britaniya Elektrokonvulsiv Terapiya (EKT) İcmal Qrupu. Depressiv pozuntularda elektrokonvulsiv terapiyanın effektivliyi və təhlükəsizliyi: sistematik icmal və meta-analiz. «Lancet». 2003;361(9360):799–808.
16. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Texnologiyanın Qiymətləndirilməsi 59: Elektrokonvulsiv terapiyadan istifadə üzrə təlimat. 2003 (yenidən baxılmış).

XBT-11 **6A22**	**6A22 ŞİZOTİPİK POZUNTU** **Schizotypal disorder**
XBT-10 F21	Şizotipik pozuntu
DSM-5-TR F21	Şizotipik şəxsiyyət pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Şizotipik pozuntu (XBT-11: 6A22 Şizotipik pozuntu (ing. Schizotypal Disorder); DSM-5-TR: F21 Şizotipik şəxsiyyət pozuntusu (ing. Schizotypal Personality Disorder)) — davamlı təfəkkür və qavrayış pozuntuları, qəribə (eksentrik) davranış, sosial çatışmazlıq və psixotik-bənzər təcrübələrlə xarakterizə olunan, lakin tam psixotik epizod meyarlarına çatmayan klinik vəziyyətdir.

Mühüm nozoloji məsələ: XBT-11 və DSM-5-TR-də fərqli yerləşmə:

- XBT-11 — şizofreniya spektri pozuntuları daxilində (psixotik kateqoriya) 6A22;
- DSM-5-TR — şəxsiyyət pozuntuları fəslində (A klasteri) və şizofreniya spektri pozuntuları siyahısında ikiqat kodlanır.

2. Tarixçə

- Bleuler E. (1911) — «latent şizofreniya» (latent schizophrenia) konsepsiyası — şizofreniyaya yaxın olan, lakin tam psixotik epizod olmayan vəziyyət.
- Rado S. (1953) — «şizotip» (schizotype) termini — şizofreniyaya genetik meylin daimi şəxsiyyət ifadəsi kimi.
- Kety S.S. və b. (1968) — Danimarka adoptiv tədqiqatları — şizofreniyalı bioloji qohumlarda şizotipik xüsusiyyətlər yüksəkdir; «şizofreniya spektri» (schizophrenia spectrum) konsepsiyasının əsasını qoymuşdur.
- DSM-III (1980) — Şizotipik şəxsiyyət pozuntusu (ing. Schizotypal Personality Disorder) şəxsiyyət pozuntuları arasında
- XBT-10 (1990) və XBT-11 (2019) — şizotipik pozuntu psixotik pozuntular fəslində yerləşir.

- DSM-5 (2013) ikiqat yerləşməni (şəxsiyyət pozuntuları və şizofreniya spektri) konseptual körpü kimi müəyyən edir.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma (prevalans): 0,6–4% — geniş aralıq (Pulay A.J. və b. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2009 ABŞ NESARC tədqiqatı n > 34 000 — 3,9%).
- Cins: kişilərdə nisbətən sıx; bəzi tədqiqatlarda fərq minimaldır.
- Başlanğıc dövrü: yeniyetməlik və erkən yetkinlik illəri.
- Şizofreniyaya keçid: təxminən 10–25% (Schultze-Lutter F. və b. Schizophr Res 2014); ailə tarixçəsi və əlavə psixoz riski amilləri olduqda daha yüksək.
- Komorbidlik: əhval pozuntuları, narahatlıq, maddə istifadəsi, digər şəxsiyyət pozuntuları (paranoid, şizoid və sərhəd (borderline) şəxsiyyət pozuntusu).

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

- Şizofreniya ilə paylaşılan genetik yük — Kety adoptiv tədqiqatları və müasir genetik tədqiqatlar (ing. Cross-Disorder Group 2013) — şizotipik pasiyentlərin qohumlarında şizofreniya riski artmışdır.
- Şizofreniyaya bənzər poliqen risk arxitekturası, lakin «yük» daha azdır; bəzi qoruyucu allellər mövcuddur.

4.2 Neyrobioloji

- Şizofreniyada müşahidə olunan struktur dəyişikliklərin daha yüngül variantları — temporal qabığın həcminin azalması, lakin frontal qabığın saxlanması (Hazlett E.A. və b. Schizophr Bull 2011 icmal).
- Dopaminergik disregulasiya şizofreniyaya nisbətən daha az ifadə olunmuşdur; psixotik dekompansasiya ehtimalı daha azdır.
- Koqnitiv çatışmazlıq — şizofreniyadakı kimi, lakin daha mülayimdir.

4.3 Mühit amilləri

- Uşaqlıq travması və sosial məhrumiyyət risk amilləridir.
- Kannabisin yeniyetməlik dövründə istifadəsi psixotik dekompansasiya riskini artırır.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Koqnitiv-perseptiv simptomlar

- Münasibət ideyaları (ideas of reference) — tam sayıqlama səviyyəsində deyil; pasiyent bəzən bu fikirlərin qeyri-həqiqi olduğunu qəbul edə bilər.
- Qəribə inanclar və ya magik təfəkkür — telepatiya, «altıncı hiss», xurafat inancları; yaşa və mədəniyyətə uyğun olmayan dərəcədə ifadə olunur.
- Qeyri-adi perseptiv təcrübələr — şəxsi olmayan, ötəri illyuziyalar; tam hallüsinasiya yoxdur.
- Qəribə təfəkkür və nitq (qeyri-müəyyən, dolayı, metaforik, stereotipik) müşahidə olunur.

5.2 Şəxslərarası simptomlar

- Yaxın münasibətlərdə narahatlıq və sosial təcrid müşahidə olunur.
- Paranoid ideyalar və ya şübhəlilik.
- Uyğun olmayan və ya məhdud affekt.
- Qəribə, eksentrik və ya özünəməxsus davranış və görünüş.
- Birinci dərəcəli qohumlardan başqa yaxın dostların azlığı.

5.3 Gediş

Adətən yeniyetməlikdən başlayır və davamlı gedişə malikdir; bəzi pasiyentlərdə qısamüddətli psixotik dekompansasiya epizodları (stress, kannabis kontekstində) — bu zaman diaqnoz «şizofreniya» və ya «kəskin və keçici psixotik pozuntu» kimi yenidən qiymətləndirilə bilər.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11 konsensus nöqtələri)

A. Sosial və şəxslərarası çatışmazlıq və koqnitiv-perseptiv pozuntular ilə xarakterizə olunan davamlı mənzərə, yetkin yaşda başlayan, aşağıdakı simptomların ən azı beşi:

1. Münasibət ideyaları (referans sayıqlamaları istisna);
2. Yaşa və mədəniyyətə uyğun olmayan qəribə inanclar və ya magik təfəkkür;
3. Qeyri-adi perseptiv təcrübələr (illyuziyalar daxil olmaqla);
4. Qəribə təfəkkür və nitq (qeyri-müəyyən, dolayı, metaforik, stereotipik);
5. Şübhəlilik və paranoid ideyalar;
6. Uyğun olmayan və ya məhdud affekt;

7. Qəribə, eksentrik və ya özünəməxsus davranış və ya görünüş;
8. Birinci dərəcə qohumlardan başqa yaxın dostların və ya sirdaşların azlığı;
9. Tanışlıqla azalmayan həddindən artıq sosial narahatlıq (paranoid qorxuya əsaslanır, özünə qiymət baxımından deyil).

B. Yalnız davamlı şizofreniya, psixotik xüsusiyyətlərlə affektiv pozuntu, digər psixotik pozuntu və ya autizm spektri pozuntusu gedişində baş vermir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 (6A22): «Şizotipik pozuntu» (Schizotypal Disorder) — psixotik pozuntular fəslində; davamlı pozuntu kimi müəyyən edilir, lakin şizofreniya meyarlarına çatmır.
- DSM-5-TR (F21): ikiqat kodlama — A klasteri şəxsiyyət pozuntuları və şizofreniya spektri siyahısında. Yetkin yaş tələb olunur; uşaqlıq və yeniyetməlik dövründə «premorbid əlamətlər» kimi qeyd oluna bilər.
- NICE: şizotipik pozuntu üzrə ayrı klinik göstəriş yoxdur; CG78 (ŞPP) və CG178 (Psixoz) prinsipləri tətbiq olunur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə, qohumlardan və dostlardan alınan məlumat — davamlı şəxsiyyət xüsusiyyətləri və ya episodik psixoz.
2. Strukturlaşdırılmış müsahibə — SCID-5-PD (ing. Personality Disorders), SIDP-IV.
3. Şizotipiya şkalaları — SPQ (ing. Schizotypal Personality Questionnaire, Raine A.).
4. Psixotik simptomların ayrılıqda qiymətləndirilməsi — PANSS-də pozitiv simptomların subklinik səviyyəsi.
5. Komorbidliyin ilk aşkarlanması (depressiya, narahatlıq, maddə istifadəsi, digər şəxsiyyət pozuntuları).
6. Tibbi və neyroloji müayinə, toksikoloji skrininq.
7. Şizofreniyaya keçid riskinin qiymətləndirilməsi (ultra yüksək risk (ultra-high risk) meyarları — CAARMS, SIPS).

6.4 Differensial diaqnostika

Pozuntu	Fərqləndirici əlamətlər
Şizofreniya (6A20)	Tam psixotik epizod ≥ 1 ay; funksional pozulma əhəmiyyətlidir.

Pozuntu	Fərqləndirici əlamətlər
Sayıqlama pozuntusu (6A24)	Konkret sistemləşdirilmiş sayıqlama, ümumi funksiya nisbətən saxlanılır.
Paranoid şəxsiyyət pozuntusu (XBT-11: 6D10, A klasteri əlamətləri ilə)	Şübhəlilik dominant; perseptiv qəribə təcrübələr yoxdur.
Şizoid şəxsiyyət pozuntusu	Sosial təcrid, lakin koqnitiv-perseptiv qəribəliklər yoxdur.
Autizm spektri pozuntusu (6A02)	Erkən başlanğıc, sosial-kommunikativ çatışmazlıq, məhdud-təkrarlanan davranış.
ŞPP (6D10.x)	Emosional dəyişkənlik, identikliyin pozulması, impulsivlik.
Psixoaktiv maddə ilə yaranan psixotik pozuntu (XBT-11: 6C4)	Maddə istifadəsi və ya kəsilməsi ilə əlaqəli.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik şkalalar

- SPQ (ing. Schizotypal Personality Questionnaire, Raine A.) — 74 maddə, özünüqiymətləndirmə; 9 alt-şkala (DSM meyarları əsasında).
- SCID-5-PD — strukturlaşdırılmış şəxsiyyət pozuntuları müsahibəsi.
- CAARMS (ing. Comprehensive Assessment of At Risk Mental States) — şizofreniyaya keçid riskinin qiymətləndirilməsi.
- SIPS (ing. Structured Interview for Prodromal Syndromes).
- PANSS, BPRS — psixotik simptomların subklinik səviyyəsi.

7.2 Laborator müayinələr

Rutin xüsusi göstəriş yoxdur. Standart psixiatrik ilkin göstəricilər (ümumi qan analizi, tiroid, qaraciyər, böyrək, qlükoza); toksikoloji skrininq.

7.3 İnstrumental müayinələr

Rutin tələb olunmur; klinik şübhə olduqda neyrovizualizasiya tətbiq edilir.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər

1. Birinci xətt müalicəsi — psixoterapiya — dəstəkləyici psixoterapiya (ing. supportive psychotherapy), koqnitiv-davranış terapiyası (KDT; xüsusilə paranoid təfəkkür və sosial narahatlıq üçün), sosial bacarıq təlimi.
2. Farmakoterapiya simptomatikdir, «nüvə» pozuntunu sağaltmır:
    - Aşağı dozalı antipsixotik (risperidon 0,5–2 mq, olanzapin 2,5–10 mq, aripiprazol 2–10 mq) — psixotik-bənzər simptomlar üçün; davamlı deyil, aralıq (intermittent) rejimdə.
    - Seçici serotonin geri alım inhibitorları (SSGİ) sosial narahatlıq və komorbid depressiya üçün təyin edilir.
    - Qısamüddətli benzodiazepinlər kəskin narahatlıq üçün təyin edilir.
3. Erkən müdaxilə xidmətləri (EIP) — şizofreniyaya keçid riski olan pasiyentlərdə (UHR — ultra yüksək risk meyarları) profilaktik müdaxilə.
4. Psixososial dəstək — funksional səviyyənin saxlanması, məşğulluq, sosial əlaqələr.
5. Kannabisdən imtina — psixotik dekompansasiya riskini azaltmaq üçün kritikdir.
6. Stresin idarə edilməsi — stress dekompansasiya tətikləyicisi ola bilər.
7. Ailə psixoedukasiya — şizofreniyaya keçid markerləri haqqında məlumat; pasiyentin sosial dəstək sistemi gücləndirilir.

8.2 Psixoterapiya yanaşmaları

- KDT — paranoid təfəkkür, sosial narahatlıq, koqnitiv pozulmalar üçün; reallığın qiymətləndirilməsi və alternativ izahların araşdırılması.
- Sosial bacarıq təlimi — sosial təcrid və qəribə davranışların azaldılması.
- Mentalization-based və supportiv yanaşmalar — şəxslərarası funksional səviyyənin gücləndirilməsi.
- Sxem terapiyası (ing. schema therapy) şəxsiyyət əsaslı davamlı modellər üçün tətbiq olunur.

8.3 Farmakoterapiya — konkret istifadə

- Subklinik psixotik simptomlar (referans fikirləri, qəribə təcrübələr) ağırlaşdıqda — aşağı doza atipik antipsixotik intermitent.
- Komorbid depressiya — SSGİ (sertralin, essitalopram).

- Sosial narahatlıq — SSGİ, qısamüddətli benzodiazepin (xüsusi vəziyyətlər üçün).
- Streslə tətiklənən dekompansasiya — xəstəxanaya yerləşdirmə və ya qısamüddətli intensiv müdaxilə.

8.4 Müalicə metodikaları

1. Şizotipik Şəxsiyyət Şkalası (ing. Schizotypal Personality Questionnaire, SPQ) — Reyn (Raine A.) — 74 maddəlik özünüqiymətləndirmə şkalası; DSM şizotipik şəxsiyyət pozuntusu meyarlarına uyğun 9 alt-şkala. Klinik və əhali tədqiqatlarında geniş istifadə olunur.
2. Risk Altında Psixi Vəziyyətlərin Kompleks Qiymətləndirməsi (ing. Comprehensive Assessment of At Risk Mental States, CAARMS) şizofreniyaya keçid riskinin qiymətləndirilməsi — pozitiv simptomların subklinik səviyyəsi, koqnitiv dəyişikliklər, davranış pozuntuları, funksional səviyyə. Yung A.R. və b. Aust N Z J Psychiatry 2005.
3. Prodromal Sindromlar üçün Strukturlaşdırılmış Müsahibə (ing. Structured Interview for Prodromal Syndromes, SIPS) — Miller T.J. və McGlashan T.H. — CAARMS-ə bənzərdir; ABŞ-da geniş istifadə olunur.
4. Erkən Müdaxilə Xidmətləri (EIP) — UHR pasiyentlər üçün — multidissiplinar müdaxilə; profilaktik vasitə kimi antipsixotik adətən tövsiyə edilmir (yan təsir yükü), psixososial müdaxilə üstündür.
5. Şəxsiyyət pozuntularına uyğunlaşdırılmış KDT — Şizotipik şəxsiyyət üçün — koqnitiv pozulmalar, sosial qorxular, paranoid təfəkkür üzərində iş.
6. Sosial bacarıq təlimi (ing. social skills training) — Strukturlaşdırılmış qrup və ya fərdi seanslar — sosial qarşılıqlı əlaqə bacarıqlarının inkişafı.

8.5 Mənbələr arasında fərqlər

- Sübut bazası məhduddur — şizotipik pozuntunun spesifik müalicəsi üzrə geniş RKİ-lər azdır; əsas yanaşma şizofreniya və şəxsiyyət pozuntuları müdaxilələrindən ekstrapolyasiya olunur.
- Koenigsberg H.W. və b. tədqiqatları — şizotipik pozuntu üzrə aşağı doza antipsixotik tədqiqatları (mülayim effekt).
- NICE — ayrı göstəriş yoxdur; CG178 (psixoz) və CG78 (sərhəd şəxsiyyət pozuntusu) prinsipləri.

9. Proqnoz

9.1 Yaxşı proqnoz amilləri

- Yüngül simptom intensivliyi.

- Komorbidliyin (depressiya, narahatlıq, maddə) idarə edilməsi.
- Sosial dəstək və davamlı münasibətlər.
- Psixoterapiya iştirakı.
- Kannabisdən imtina.

Pis proqnoz amilləri

- Ailə tarixçəsində şizofreniya.
- Kannabis və ya digər psixoaktiv maddə istifadəsi.
- Ağır koqnitiv çatışmazlıq.
- Sosial təcrid və funksional pozulma.
- Ultra yüksək risk (UHR) meyarlarına çatma ehtimalı.

İzləmə hədəfləri

- Şizofreniyaya keçid markerlərinin (CAARMS / SIPS) dövri qiymətləndirilməsi.
- Komorbidlik skrininq (depressiya, narahatlıq, maddə).
- Funksional səviyyə — məşğulluq, sosial əlaqələr.
- Stress və psixotik dekompansasiya tətikləyicilərinin idarə edilməsi.
- Antipsixotik qəbul edənlərdə yan təsirlərin monitorinqi aparılır.

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya və konseptual mifləri

Mif 1: «Şizotipik şəxsiyyət — sadəcə „eksentrik“ və ya „yaradıcı“ insandır, klinik diaqnoz tələb etmir»

Niyə yayılmışdır: şizotipik xüsusiyyətlərin (qəribə inanclar, eksentriklik) əhalidə davamlı spektrum kimi yayılması — ümumi əhalidə «şizotipiya» (schizotypy) xüsusiyyətlərini yüngül formada çoxları daşıyır.

Klinik və bioloji məntiq: klinik diaqnoz funksional pozulma tələb edir — sosial təcrid, peşə pozulması, narahatlıq. Sadə yaradıcılıq və ya eksentriklik özü-özlüyündə diaqnoz əsası deyil. Lakin diaqnostik meyarlara çatdıqda şizotipik pozuntu real klinik vəziyyət sayılır və müdaxilə tələb edir.

Real klinik addım: diaqnoz meyarları (5/9 simptom + funksional pozulma) əsasında qoyulmalıdır.

Mif 2: «Şizotipik pozuntu mütləq şizofreniyaya çevrilir»

Sübut: Schultze-Lutter F. və b. Schizophr Res 2014 — şizotipik pozuntudan şizofreniyaya keçid təxminən 10–25%; çoxluq stabil qalır və ya remissiya göstərir. Ailə tarixçəsi, kannabisdən istifadə, koqnitiv defisitin ağırlığı keçid riskini artırır.

Real klinik addım: ailəyə realist proqnoz; UHR meyarları izlənir; profilaktik antipsixotik adətən tövsiyə edilmir.

Mif 3: «Şizotipik pozuntu uşaqlıq travmasından və ya pis tərbiyədən yaranır»

Sübut: genetik komponent əhəmiyyətlidir — Kety Danimarka adoptiv tədqiqatları; Cross-Disorder Group 2013. Uşaqlıq travması risk amili kimi göstərilir, lakin əsas etiologiya deyil; bioloji və psixososial qarşılıqlı təsir.

10.2 Yanlış müalicə yanaşmaları

Mif 4: «Şizotipik pasiyentlər mütləq davamlı antipsixotik almalıdır»

Sübut: şizotipik pozuntu üçün davamlı antipsixotik tövsiyə edilmir (sübut bazası məhdud + yan təsir yükü). Aşağı dozalı antipsixotik aralıq, simptoma yönəlmiş müdaxilə kimi istifadə oluna bilər; davamlı təyin üçün — fərdi qiymətləndirmə.

Mif 5: «Şizotipik pasiyentin „magik təfəkkürünü“ təsdiqləmək müalicədir»

Klinik məntiq: sayıqlama-bənzər inancları açıq şəkildə təsdiqləmək onları gücləndirir; əksinə, açıq şəkildə inkar etmək də terapevtik ittifaqı pozur. Reallığın qiymətləndirilməsi və alternativ izahlar KDT-də sübutlu yanaşmadır — pasiyentlə birlikdə inancın faktiki sübutu və ya alternativ izahları araşdırılır.

Mif 6: «Sosial təcrid sağlam strategiyadır, şizotipik pasiyenti tək buraxmaq lazımdır»

Sübut: sosial təcrid uzunmüddətli funksional pozulmanı və əhval pozuntuları riskini artırır. Sosial bacarıq təlimi və supportiv terapiya ilə tədricən sosial əlaqələrin gücləndirilməsi tövsiyə edilir.

10.3 Səmərəsiz və ya əsas müdaxiləni təxirə salan üsullar

Mif 7: «Magik təfəkkür və „altıncı hiss“ əsaslı alternativ klinikalar şizotipik pozuntunu sağaldır»

Sübut: «ezoterik müdaxilələr» (kristal terapiyası, çakra çalışmaları, astrologiya məsləhətləri) — şizotipik pasiyentin qəribə inanclarını dəstəkləyə bilər və

pozuntunun simptomlarını gücləndirə bilər. Effekt sübutu yoxdur; əsas psixoterapevtik və ya farmakoterapevtik müdaxiləni təxirə salır.

Mif 8: «Kannabis „yaradıcılıq və qəribə təcrübələri saxlayır“ — şizotipik pasiyent üçün təhlükəsizdir»

Sübut: kannabis psixoz riskini 2–3 dəfə artırır (Marconi 2016); şizotipik pasiyentlərdə şizofreniyaya keçid riski daha yüksəkdir. Kannabisdən imtina kritik klinik tövsiyədir.

Mif 9: «Homeopatiya, akupunktura, ezoterik müdaxilələr şizotipik pozuntunu sağaldır»

Sübut: sistematik icmallar (Cochrane) — bu müdaxilələrin şizotipik pozuntuya təsiri sübut edilməmişdir.

Mif 10: «Şizotipik pasiyent psixoterapiyaya cavab vermir, ona görə sadə müşahidə kifayətdir»

Sübut: KDT, sosial bacarıq təlimi və supportiv psixoterapiya bu pasiyentlərə kömək edə bilər; «müşahidə kifayətdir» yanaşması funksional pozulmanı artırır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və xəstələnmə statistikası üzrə Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A22 Şizotipal pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). Vaşinqton: APA Nəşriyyatı; 2022.
3. Pulay A.C., Stinson F.S., Dawson D.A. və b. DSM-IV şizotipal şəxsiyyət pozuntusunun yayılması, korrelyatları, əlilliyi və komorbidliyi: Alkoqol və Əlaqəli Vəziyyətlər üzrə Milli Epidemiologiya Sorğusunun 2-ci dalğasının nəticələri. «Birinci Səhiyyə üzrə Klinik Psixiatriya Jurnalı» (Prim Care Companion J Clin Psychiatry). 2009;11(2):53–67.
4. Şultze-Lutter F., Klosterkötter C., Ruhrmann S. Ultra yüksək risk meyarları ilə koqnitiv baza simptomlarının birləşdirilməsi yolu ilə psixozun klinik proqnozlaşdırılmasının yaxşılaşdırılması. «Şizofreniya Tədqiqatları» (Schizophr Res). 2014;154(1–3):100–106.
5. Hazlett E.A., Goldstein K.E., Kolaitis C.C. Şizotipal şəxsiyyət pozuntusunda struktur MRT və diffuziya tensor görüntüləməsinə dair icmal. «Müasir Psixiatriya Hesabatları» (Curr Psychiatry Rep). 2012;14(1):70–78.
6. Raine A. SPQ: DSM-III-R meyarlarına əsaslanan şizotipal şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi şkalası. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 1991;17(4):555–564.

7. Yunq Ə.R., Yuen H.P., MakQorri P.D. və b. Psixozun başlanğıcının xəritələnməsi: Risk qrupunda olan psixi vəziyyətlərin kompleks qiymətləndirilməsi. «Avstraliya və Yeni Zelandiya Psixiatriya Jurnalı» (Aust N Z J Psychiatry). 2005;39(11–12):964–971.
8. Psixiatrik Genomika Konsorsiumunun Transpozuntular Qrupu. Beş əsas psixiatrik pozuntuda ümumi təsirə malik risk lokuslarının identifikasiyası: bütün genom üzrə analiz. «Lancet». 2013;381(9875):1371–1379.
9. Markoni Ə., Di Forti M., Lyuis K.M., Murray R.M., Vassos E. Kannabis istifadəsinin səviyyəsi ilə psixoz riski arasında əlaqənin meta-analizi. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2016;42(5):1262–1269.
10. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik Rəhbərlik 178. Yetkinlərdə psixoz və şizofreniya: profilaktika və idarəedilmə. 2014, 2019-cu il yenilənməsi.
11. Keti S.S., Rozental D., Vender P.H. və b. Övladlığa götürülmüş şizofreniya xəstələrinin bioloji və övladlığa götürən ailələrində psixi xəstəliyin növləri və yayılması. «Psixiatriya Tədqiqatları Jurnalı» (J Psychiatr Res). 1968;6(Əlavə 1):345–362.
12. Miller T.C., MakQlaşan T.H., Rozen C.L. və b. Prodromal sindromlar üçün Strukturlaşdırılmış Müsahibə və Prodromal Simptomlar Şkalası ilə prodromal qiymətləndirmə. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2003;29(4):703–715.
13. Königsberq H.V., Reynolds D., Qudman M. və b. Şizotipal şəxsiyyət pozuntusunun müalicəsində risperidon. «Klinik Psixiatriya Jurnalı» (J Clin Psychiatry). 2003;64(6):628–634.

XBT-11 **6A23**	**6A23 KƏSKİN VƏ KEÇİCİ PSİXOTİK POZUNTU** **Acute and transient psychotic disorder**
XBT-10 F23	Kəskin və keçici psixotik pozuntular
DSM-5-TR F23	Qısamüddətli psixotik pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Kəskin və keçici psixotik pozuntu (XBT-11: 6A23 Acute and Transient Psychotic Disorder; DSM-5-TR: Qısamüddətli psixotik pozuntu (ing. Brief Psychotic Disorder; 298.8)) — sürətli (bir neçə gün–həftə) başlayan, psixotik simptomlar (sayıqlama, hallüsinasiya, dezorqanizə nitq, kobud dezorqanizə olunmuş davranış) ilə xarakterizə olunan, qısamüddətli gediş və premorbid funksional səviyyəyə tam bərpa ilə nəticələnən pozuntudur.

Xarakterik xüsusiyyətlər:

- Sürətli başlanğıc — 2 həftə içində tam klinik mənzərənin formalaşması;
- Polimorf (çoxşəkilli) simptomlar — sayıqlamalar, hallüsinasiyalar və emosional dalğalanma birgə;
- Qısa müddət — DSM-5-TR-də 1 gündən çox, lakin 1 aydan az; XBT-11-də 3 aydan az;
- Funksional bərpa — pasiyent premorbid səviyyəyə qayıdır.

2. Tarixçə

- Magnan V. (1893) — «bulif deliran» (bouffée délirante) termini — Fransada sürətli başlayan, qısamüddətli polimorf psixotik epizodların təsviri.
- Wernicke K., Kleist K., Leonhard K. (1900–1957) — «siklik psixozlar» konsepsiyası — Alman psixiatriya məktəbində; sürətli başlanğıc və yaxşı proqnoz.
- Skandinaviya məktəbi — «psixogen psixoz» — Strömgren E. (1940) — stress və ya travma kontekstində psixoz.
- DSM-III (1980) — «reaktiv psixoz» (Brief Reactive Psychosis) — stres amili tələbi ilə.
- DSM-IV (1994) və DSM-5 (2013) — stress faktoru meyarı ləğv edilmişdir (kvalifikator kimi qalıb); «Brief Psychotic Disorder» termini.
- XBT-11 (2019) — «kəskin və keçici psixotik pozuntu» (acute and transient psychotic disorder) termini saxlanılmışdır; 3 aylıq müddət; polimorf simptomatika vurğulanır.

3. Epidemiologiya

- İllik insidens: 3,9–9,6 / 100 000 (Castagnini A., Berrios G.E. Curr Psychiatry Rep 2009 icmal).
- Cins: qadınlarda nisbətən sıx (1,5–2:1) — xüsusilə postpartum kontekstdə.
- Başlanğıc yaşı: 20–35 yaş; şizofreniyaya nisbətən bir az gecdir.

- Mədəni və coğrafi: aşağı və orta gəlirli ölkələrdə yayılma göstəricisi daha yüksək (Susser E. və b. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998 ÜST 10 ölkə tədqiqatı).
- Doğuşdan sonrakı başlanğıc postnatal psixoz kateqoriyasına aiddir (XBT-11: 6E20).
- Persistensiya və diaqnozun dəyişməsi: pasiyentlərin 30–50%-i uzunmüddətli izləmədə şizofreniya, şizoaffektiv pozuntu və ya bipolyar pozuntu kimi yenidən diaqnozlanır (Castagnini A. və b. Schizophr Res 2013).

4. Etiologiya və patogenez

4.1 Genetik amillər

- Şizofreniya və bipolyar pozuntu ilə qismən paylaşılan genetik risk mövcuddur.
- Ailə tarixçəsində psixotik və ya affektiv pozuntu olduqda risk artır.

4.2 Tətikləyicilər və stress

- Kəskin psixososial stress (ölüm, qaçqınlıq, təbii fəlakət) — pasiyentlərin əhəmiyyətli hissəsində müəyyən edilir; DSM-5-TR-də stress kvalifikatoru kimi göstərilir.
- Doğuşdan sonrakı dövr hormonal dəyişikliklər və yuxu pozuntuları ilə müşayiət olunur.
- Maddə istifadəsi — kannabis, amfetamin, hallüsinogenlər — psixotik epizodu tətikləyə bilər, lakin maddə müəyyən olduqda maddə ilə yaranan psixoz ayrı kateqoriya kimi kodlanır.
- Qısamüddətli yuxusuzluq və intensiv emosional gərginlik.

4.3 Neyrobioloji mexanizmlər

- Dopaminergik sistemin müvəqqəti hiperaktivliyi stres kortizolunun təsiri və ya hormonal dəyişikliklər zəminində yaranır.
- Şizofreniyadakı kimi mərkəzi mexanizmlər iştirak edir, lakin onlar daha qısamüddətli və potensial olaraq geri çevrilə biləndir.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Klassik klinik mənzərə

- Sürətli başlanğıc — günlər–həftələr ərzində premorbid normal funksiyadan tam psixotik şəklə.

- Polimorf (çoxşəkilli) simptomlar — sayıqlamalar (təqib, münasibət, dini), hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə, senestetik (koenestetik)), dezorqanizə olunmuş nitq.
- Emosional dalğalanma — kəskin qorxu, ekstaz, panik, şaşkınlıq.
- Şüur dəyişiklikləri yoxdur (delirium istisna olmaqla).
- Davranış qəribə və dezorqanizə olunmuşdur; bəzən katatonik komponentlər müşahidə olunur.

5.2 XBT-11 alt-tipləri

- 6A23.0 Şizofreniya simptomları olmayan polimorf psixotik pozuntu;
- Polimorf psixotik pozuntu — şizofreniya simptomları ilə;
- Şizofreniya kimi kəskin psixotik pozuntu — Şnayderin birinci dərəcəli simptomları üstünlük təşkil edir.

5.3 Gediş

Tipik gediş — 2–4 həftədə simptomların ən yüksək səviyyəyə çatması, sonra tədricən və ya sürətli geriləmə. Tam bərpa — 1 ay (DSM-5-TR) və ya 3 ay (XBT-11) ərzində. Bu müddətdən artıq davam etdikdə diaqnoz şizofreniform pozuntuya (DSM-5-TR: 295.40; 1–6 ay) və ya şizofreniyaya keçirilir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11 konsensus nöqtələri)

A. Bir və ya bir neçə psixotik simptomun mövcudluğu:

1. Sayıqlamalar;
2. Hallüsinasiyalar;
3. Dezorqanizə olunmuş nitq;
4. Kobud dezorqanizə olunmuş və ya katatonik davranış.

(Ən azı biri 1, 2 və ya 3 olmalıdır.)

B. Epizodun müddəti:

- DSM-5-TR: ≥ 1 gün, < 1 ay, sonra premorbid funksiya səviyyəsinə tam bərpa.
- XBT-11: tam klinik mənzərə 2 həftə içində formalaşır; < 3 ay davam edir.

C. İstisnalar — psixotik xüsusiyyətlərlə affektiv pozuntu, şizofreniya, şizoaffektiv pozuntu, maddə ilə induksiyalanmış psixoz, üzvi psixoz ilə tam izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: kvalifikatorlar — «with marked stressor(s)» (kəskin stress faktoru ilə), «kəskin stress faktoru olmadan» (without marked stressor), «doğuşdan sonrakı başlanğıc» (with postpartum onset) (doğuşdan 4 həftə içində).
- XBT-11 (6A23): iki alt tip — polimorf (şizofreniya simptomları olmadan və ya onlarla) və şizofreniya kimi. Doğuşdan sonrakı başlanğıc ayrı 6E20 koduna aiddir.
- Stress faktoru meyar deyil, kvalifikatordur — DSM-IV-də «qısa reaktiv psixoz» (Brief Reactive Psychosis) çərçivəsində məcburi idi.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + qohumlardan məlumat — başlanğıc dinamikası, premorbid funksiya.
2. Strukturlaşdırılmış müsahibə (SCID-5, MINI).
3. Şiddət şkalaları — PANSS, BPRS.
4. Toksikoloji skrininq (mütləq) — Maddə ilə induksiyalanmış psixozu istisna etmək üçün toksikoloji skrininq mütləqdir.
5. Cismani və neyroloji müayinə.
6. Laborator müayinələr: ümumi qan analizi, qaraciyər və böyrək funksiyası, elektrolitlər, qlükoza, tiroid stimulyasiya edən hormon (TSH), B12 vitamini, sifilis, insan immunçatışmazlığı virusu (HIV).
7. EEQ və beyin MRT — ilk epizod və ya atipik klinik mənzərə.
8. Doğuşdan sonrakı dövrdə — tiroid funksiyası mütləq.
9. İntihar və uşağa zərər riskinin qiymətləndirilməsi (postpartum hallarda).
10. İzləmə — diaqnoz müddətə əsasən dəyişə bilər (1 və ya 3 aylıq müddət ötəndə).

6.4 Differensial diaqnostika

Pozuntu	**Fərqləndirici əlamətlər**
Şizofreniya (6A20)	Davam ≥ 1 ay (XBT-11) / ≥ 6 ay (DSM-5-TR ümumi); qalıq əlamətlər.
Şizoaffektiv pozuntu (6A21)	Affektiv epizod psixotik simptomların əhəmiyyətli hissəsində müşahidə edilir.
Şizofreniform pozuntu (DSM-5-TR; XBT-10 üzrə F20.81)	DSM-5-TR-də 1–6 ay; XBT-11-də ayrı kod yoxdur.

Pozuntu	Fərqləndirici əlamətlər
Bipolyar I psixotik xüsusiyyətlərlə (6A60.x)	Manik epizod kontekstində.
Postpartum psixoz (6E20)	Doğuşdan 4 həftə içində; uşaq qətli və ana intiharı riski yüksəkdir — tibbi təcili — tibbi təcili.
Maddə induksiyalı psixoz	Maddə (kannabis, amfetamin, hallüsinogen) ilə aydın vaxt əlaqəsi; toksikoloji skrininq.
İkincili psixotik pozuntu (6E61)	Üzvi səbəb (autoimmun ensefalit, lupus, paraneoplastik proseslər) ilə əlaqəlidir.
Deliriya	Şüur dəyişikliyi; diqqət fluktuasiyası; üzvi səbəb.
Dissosiativ epizod	Travma kontekstində; dissosial təcrid üstünlük təşkil edir.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

7.1 Klinik şkalalar

- PANSS və BPRS — psixotik simptomların şiddətinin qiymətləndirilməsi.
- HAM-D (Hamilton Depressiya Şkalası) və YMRS (Young Maniya Reytinq Şkalası) — affektiv komponentlərin qiymətləndirilməsi.
- C-SSRS — intihar riskinin qiymətləndirilməsi.
- GAF/PSP — funksional səviyyə.

7.2 Laborator müayinələr

İlk epizod psixoz protokoluna uyğun (bax 6A20 §7.2):

- Mütləq: tam qan, qaraciyər/böyrək, qlükoza, elektrolitlər, TSH, B12, folat, toksikoloji skrininq, HIV, sifilis, hamiləlik testi, prolaktin.
- Üzvi psixoz şübhəsi varsa — anti-NMDA-R antikorları (beyin onurğa mayesində — BOS), ANA, lupus paneli, paraneoplastik antikor paneli, ammonyak, seruloplazmin.
- Postpartum kontekstdə — TSH (postpartum hipotiroid mümkündür).

7.3 İnstrumental müayinələr

- Beyin MRT — ilk epizodda tövsiyə edilir (NICE CG178); xüsusilə atipik təzahür və ya neyroloji əlamətlər olduqda.
- EEQ — tutmaların istisnası üçün, atipik klinik tablo.
- EKG — antipsixotik müalicəyə başlanmazdan əvvəl.
- Lumbal punksiya — autoimmun ensefalit şübhəsi (atipik psixoz, hərəkət simptomları və qadın cinsi).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər

1. Təcili qiymətləndirmə və lazım olduqda hospitalizasiya — pasiyentin və ya başqalarının təhlükəsizliyi üçün.
2. Birinci sıra: atipik antipsixotik aşağı dozada — risperidon 1–4 mq, olanzapin 5–15 mq, kvetiapin 200–600 mq, aripiprazol 5–15 mq.
3. Kəskin agitasiyada — oral lorazepam 1–2 mq + olanzapin ağızda əriyən (ing. orally disintegrating) 5–10 mq; əzələdaxili — olanzapin 10 mq əzələdaxili (intramüskulyar) və ya aripiprazol 9,75 mq im, lazımdırsa haloperidol 5 mq + lorazepam 2 mq im (klassik).
4. Müddət — antipsixotik tipik 3–6 ay (remissiyadan sonra), sonra tədricən azaltma və monitorinq; ilk epizodda dərmanın kəskin dayandırılması standart yanaşma deyil — fərdi qiymətləndirmə.
5. Stress-induksiyalı kontekstdə — psixososial dəstək, KDT-əsaslı stress idarəsi.
6. Postpartum başlanğıcda — tibbi təcili hal kimi; uşaq qətli və intihar riski yüksəkdir; xəstəxanada stasionar müalicə, ana-uşaq birgə yerləşdirmə şərtləri varsa, üstün tutulur; bax 6E20 fəsli.
7. Elektrokonvulsiv terapiya (EKT) — müalicəyə davamlı ağır hallarda, katatonik xüsusiyyətlərlə, hamiləlikdə ən təhlükəsiz seçim.
8. Uzunmüddətli izləmə — pasiyentlərin 30–50%-i uzunmüddətli psixotik pozuntuya keçir; ilk il ərzində aylıq, sonra rüblük.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Erkən Müdaxilə Xidmətləri (ing. EIP — Early Intervention in Psychosis) — İlk psixotik epizod üçün multidissiplinar qayğı 3 il ərzində — aşağı doza farmakoterapiya, KDTp, ailə müdaxiləsi, məşğulluq dəstəyi. RAISE (Kane J.M. və b. Am J Psychiatry 2016) RKİ. Kəskin və keçici pasiyentlər də Erkən Müdaxilə Xidmətləri (EMX) proqramlarına daxil edilir.

2. Psixoz üçün Koqnitiv-Davranış Terapiyası (KDTp — psixoz üçün koqnitiv-davranış terapiyası) — Psixotik simptomları «düşüncə-emosiya-davranış» formulasiyasında yenidən qiymətləndirmə. NICE CG178 §1.3.7.1.
3. Ailə psixoedukasiyası (ing. Family Psychoeducation) — Pasiyentin epizoddan sonra dəstəyi, residivin erkən əlamətlərinin tanınması, ailə ünsiyyət təlimi. Pharoah Cochrane 2010.
4. Elektrokonvulsiv Terapiya (ing. Electroconvulsive Therapy, EKT) — Katatonik xüsusiyyətlərlə, ağır farmakoterapiya cavabsızlığında, hamiləlikdə. NICE TA59. UK EKT Review Group Lancet 2003.
5. PANSS və BPRS — psixotik şiddətin standartlaşdırılmış qiymətləndirilməsi.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG178 (psixoz və şizofreniya): ilk epizod psixozun idarə edilməsi prinsipləri — atipik antipsixotik aşağı dozada birinci sıra; erkən müdaxilə xidmətləri (EIP) iştirak; psixososial müdaxilə birgə.
- APA Practice Guideline 2021 (Schizophrenia): kəskin və keçici psixotik pozuntu üçün spesifik alqoritm yoxdur; ilk epizod psixoz prinsipləri.
- NICE CG192 (doğuşdan əvvəlki və sonrakı psixi sağlamlıq): postnatal psixoz tibbi təcili — xəstəxana yatımı, atipik antipsixotik + benzodiazepin, EKT refrakter hallarda.

9. Proqnoz

Yaxşı proqnoz amilləri

- Çox sürətli başlanğıc və qısa müddət.
- Aydın stress amili.
- Premorbid yaxşı funksional səviyyə.
- Affektiv komponentin mövcudluğu.
- Polimorf simptomatika (şizofreniya simptomları olmadan).
- Ailə tarixçəsində psixotik pozuntu olmaması.
- Kannabis və ya digər maddə istifadəsi olmaması.

Pis proqnoz amilləri

- Şizofreniya kimi simptomlar (Şnayder I dərəcəli əlamətlər).
- Stress tətikləyicisinin olmaması.
- Tədricən başlanğıc.
- Premorbid funksional zəiflik.

- Ailə tarixçəsində şizofreniya.
- Maddə istifadəsi.

İzləmə hədəfləri

- Uzunmüddətli izləmə kritikdir — 30–50% şizofreniya, şizoaffektiv və ya bipolyar pozuntuya keçir; ilk il aylıq, sonra rüblük rəsmi izləmə.
- Residiv markerlərinin tanınması (yuxu pozuntusu, sosial geri çəkilmə, qəribə təcrübələr).
- Antipsixotik dozanın tədricən azaldılması və kəsilməsi — fərdi qərar (residiv riski və ya yan təsir).
- Komorbid maddə istifadəsi və travma müdaxiləsi.
- Postpartum hallarda — sonrakı hamiləliklərdə residiv riski yüksəkdir, profilaktik müalicə planlaşdırılır.

10. Mif və yanlış inanclar

10.1 Etiologiya və konseptual mifləri

Mif 1: «Kəskin və keçici psixoz „yalnız psixoloji sarsıntıdır“, iradə zəifliyinə bağlıdır»

Niyə yayılmışdır: stress ilə vaxt əlaqəsi və qısamüddətli gedişat «psixoloji» izahatı dəstəkləyir kimi görünür.

Klinik və bioloji məntiq: stress tətikləyici amildir, lakin tək başına izahat deyil — bütün stressli insanlar psixoz keçirmir. Genetik və neyrobioloji yatkınlıq mövcuddur. Castagnini 2013 sübutu — pasiyentlərin 30–50%-i şizofreniya, şizoaffektiv və ya bipolyar pozuntuya keçir; bu, neyrobioloji yatkınlığı göstərir.

Real klinik addım: stress idarəsi və psixoterapevtik dəstək vacibdir, lakin antipsixotik müalicə təxirə salınmamalıdır.

Mif 2: «Kəskin psixoz həmişə doğuşdan sonrakı psixoz qədər təhlükəlidir, yoxsa həmişə öz-özünə keçir?»

Klinik məntiq: hər kəskin psixotik epizod təcili tibbi qiymətləndirməyə layiqdir. Postpartum başlanğıcda risk xüsusilə yüksəkdir (uşaq qətli təxminən 4%, ana intiharı). Postpartum olmayan kəskin keçici epizodda da intihar və zorakılıq riski mövcuddur — pasiyentin sayıqlama məzmunu və davranış idarəsi qiymətləndirilməlidir.

Mif 3: «Stress faktorunun olması diaqnoz üçün şərtdir»

Sübut: DSM-IV-də «qısa reaktiv psixoz» (Brief Reactive Psychosis) stress faktorunu meyar kimi tələb edirdi, lakin DSM-5-TR və XBT-11-də meyar deyil, kvalifikatordur — stressli olmayan kəskin psixotik epizodlar da diaqnostik olaraq mümkündür.

10.2 Yanlış müalicə yanaşmaları

Mif 4: «Kəskin psixoz öz-özünə keçər, müalicə təxirə salına bilər»

Klinik məntiq və sübut: Marshall M. və b. Arch Gen Psychiatry 2005 — müalicəsiz psixoz dövrü (ing. MPD; duration of untreated psychosis, DUP) uzandıqca uzunmüddətli proqnoz pisləşir. Hətta keçici hesab edilən epizodda erkən antipsixotik müdaxilə simptomların qısaldılması və komplikasiyaların azaldılması üçün vacibdir.

Mif 5: «Kəskin psixotik pasiyenti tək buraxmaq olar — özünü idarə edə bilər»

Sübut: kəskin psixotik epizodda pasiyentin reallığı qiymətləndirmə qabiliyyəti pozulur; özünəqulluq, qida və su qəbulu, şəxsi təhlükəsizlik təmin edilə bilmir. Xəstəxanaya yerləşdirmə və ya gecə-gündüz nəzarət əksər hallarda tələb olunur.

Mif 6: «Kəskin keçici psixozda eksorsizm və ya dini ritual antipsixotik müalicəni əvəzləyə bilər»

Sübut: şizofreniyadakı kimi — DUP uzandıqca proqnoz pisləşir; dini-mədəni dəstək paralel ola bilər, lakin antipsixotik müalicəni əvəzləmir.

10.3 Səmərəsiz və ya zərərli yanaşmalar

Mif 7: «Kəskin psixoz „ruhani böhran“ və ya „yüksək şüura keçid“dir, müalicə zərərlidir»

Niyə yayılıb: Stan Grof və «şəxsiyyətdən kənar psixologiya» (transpersonal psixologiya) cərəyanı — psixotik təcrübələri «ruhani oyanış» kimi yenidən izah edir.

Klinik məntiq və sübut: bu yanaşma müasir klinik praktikada və sübutlu psixiatriyada qəbul edilmir. Psixotik simptomlar pasiyentə real əzab-əziyyət yaradır və risk altına qoyur; müalicədən imtinanın klinik nəticəsi əlverişsizdir (müalicəsiz psixoz dövrü uzanır).

Mif 8: «Kannabis kəskin psixotik epizodu sakitləşdirə bilər»

Sübut: kannabis psixozun tətikləyicisi və ya ağırlaşdırıcı amilidir — sakitləşdirici təsir aldadıcıdır, əslində simptomları gücləndirir; klinik praktikada əks-göstərişdir.

Mif 9: «Vitamin, omega-3, valerian, dazıotu (St John's wort) kəskin psixozda effektiv deyil»

Sübut: bu komplementar müdaxilələr kəskin psixotik epizodda təsir sübut etməmişdir; St John's Wort sitoxrom P450 induksiyası ilə antipsixotiklərin səviyyəsini azaldır (qarşılıqlı təsir).

Mif 10: «Hipnoterapiya və ya psixoanalitik dərin terapiya kəskin psixozda istifadə edilə bilər»

Sübut: kəskin psixotik epizodda dərin psixoanalitik müdaxilə pasiyenti dezorganize edə bilər; bu mərhələdə dəstəkləyici terapiya, struktur və təhlükəsizlik vacibdir, dərin müdaxilə yox.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və xəstələnmə statistikası üzrə XBT-11. 6A23 Kəskin və keçici psixotik pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Əqli pozuntuların diaqnostik və statistik təsnifatı, 5-ci nəşr, mətnin yenidən işlənməsi (DSM-5-TR). Vaşinqton: APA Publishing; 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik Rəhbərlik 178. Yetkinlərdə psixoz və şizofreniya: profilaktika və idarəedilmə. 2014, 2019-cu il yenilənməsi.
4. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik Rəhbərlik 192. Antenatal və postnatal psixi sağlamlıq: klinik idarəedilmə və xidmət üzrə rəhbərlik. 2014, 2018-ci il yenilənməsi.
5. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Şizofreniya xəstələrinin müalicəsi üzrə təcrübə rəhbərliyi, 3-cü nəşr. Vaşinqton: APA Publishing; 2021.
6. Kastanyini Ə., Berrios C.E. Kəskin və keçici psixotik pozuntular (XBT-10 F23): Avropa perspektivindən icmal. «Müasir Psixiatriya Hesabatları» (Curr Psychiatry Rep). 2009;11(4):237–247.
7. Kastanyini Ə., Bertelsen Ə., Berrios C.E. Kəskin və keçici psixotik pozuntuların diaqnozu qəbuldan 12 il sonra: izləmə tədqiqatı. «Şizofreniya Tədqiqatları» (Schizophr Res). 2013;143(1):198–203.
8. Süser E., Vanderlinq C. Qeyri-afektiv kəskin remissiyalı psixozun şizofreniya ilə müqayisədə epidemiologiyası. «Sosial Psixiatriya və Psixiatrik Epidemiologiya» (Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol). 1998;33(10):485–490.

9. Marşall M., Lyuis S., Lokvud Ə. və b. Müalicə olunmamış psixozun müddəti ilə nəticə arasında əlaqə. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(9):975–983.
10. Keyn C.M., Robinson D.C., Skuler N.R. və b. Birinci epizod psixozunda kompleks qayğı adi icma qayğısı ilə müqayisədə (RAISE). «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2016;173(4):362–372.
11. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Texnologiya Qiymətləndirilməsi 59. Elektrokonvulsiv terapiyanın istifadəsi üzrə rəhbərlik. 2003 (yenidən baxılmış).

XBT-11 **6A24**	**6A24 SAYIQLAMA POZUNTUSU** **Delusional disorder**
XBT-10 F22	Sayıqlama pozuntuları (XBT-10 F22)
DSM-5-TR F22	Sayıqlama pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Sayıqlama pozuntusu (XBT-11 üzrə 6A24 sayıqlama pozuntusu; DSM-5-TR üzrə F22) — XBT-11 üzrə ən azı 3 ay, DSM-5-TR üzrə ən azı 1 ay davam edən bir və ya bir neçə sayıqlamanın üstünlük təşkil etdiyi, lakin tam şizofreniya meyarlarına çatmayan psixotik pozuntudur. Pasiyentin ümumi davranışı və funksional səviyyəsi sayıqlama xaricində nisbətən saxlanılır.

2. Tarixçə

- Krepelin (1899) — «paranoya» — sistemləşdirilmiş sayıqlama, hallüsinasiya olmadan.
- Esquirol J.E. (1810-cu illər) — «monomania» termini; Kahlbaum K. (1863) və Krafft-Ebing R. — paranoyanın klinik təsviri.
- DSM-III-R (1987) — «sayıqlama pozuntusu» rəsmi diaqnoz kimi müəyyən edilmişdir; Kraepelin paranoia anlayışının davam etdiricisi.
- XBT-11 (2019): qəribə (bizarre) sayıqlamalara da icazə verilir (XBT-10-da yalnız qeyri-qəribə sayıqlamalar); induksiyalı sayıqlama (folie à deux) ayrıca alt tip kimi inteqrasiya edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: təxminən 0,2% (Perälä 2007).
- Başlanğıc: orta yaş (35–55 yaş), şizofreniyadan əhəmiyyətli dərəcədə gec başlayır.
- Cins: təxminən bərabər; bəzi alt-tiplərdə fərqlər (erotomaniya qadınlarda).
- Komorbidlik: depressiya, narahatlıq, sosial təcrid; intihar riski yüksək.

4. Etiologiya və patogenez

- Genetik yük şizofreniyadan az; lakin ailə tarixçəsində paranoid şəxsiyyət və psixotik pozuntu sıxlığı artmışdır.
- Sensor məhrumiyyət (eşitmə pozuntusu) — yaşlılarda paranoid sayıqlama riskini artırır.
- Sosial təcrid, miqrasiya, dil maneələri — risk amilləri.
- Neyrobioloji — dopaminergik disregulasiya, lakin şizofreniyadan daha məhdud sahəni əhatə edir; bəzi tədqiqatlarda striatal dopamin sintezinin artması (Howes O.D. icmalları).

5. Klinik təzahürlər

Alt-tiplər (sayıqlama məzmununa görə)

- Təqib (persekutor) tipi: ən çox yayılmış — başqaları tərəfindən izlənmə, zərər planlaşdırılması.
- Qısqanclıq (Othello sindromu): tərəf-müqabilinin xəyanəti haqqında sayıqlama; cinayət riski yüksək.
- Erotomanik (Clérambault sindromu): başqa şəxsin (adətən yüksək statuslu) pasiyenti sevdiyinə inam.
- Böyüklük (qrandioz): xüsusi qabiliyyət, istedad, kəşf, dini missiya.
- Somatik: bədənində parazit (Ekbom sindromu), bədənin iy ifraz etməsi, deformasiya olunması ilə bağlı inam.
- Qarışıq və qeyri-spesifik.

Funksional saxlama

Sayıqlama xaricində pasiyentin ümumi davranışı, affekt, koqnitiv funksiyalar nisbətən qorunur; iş və münasibətlər sayıqlama məzmununa toxunmadıqca davam edə bilər.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11)

A. Bir və ya bir neçə sayıqlamanın davam etməsi: XBT-11 — ən azı 3 ay (adətən daha uzun), DSM-5-TR — ən azı 1 ay.

B. Şizofreniya A meyarına çatmama (sayıqlama yeganə və ya dominant simptom; hallüsinasiya minimal və sayıqlama məzmunu ilə əlaqəli olduqda mümkündür).

C. Sayıqlamanın birbaşa təsiri olmayan funksional saxlama; davranış qəribə deyil.

D. Affektiv epizod mövcuddursa, o, sayıqlama dövrünün yalnız kiçik hissəsində müşahidə edilir.

E. Maddə və ya üzvi səbəb istisnası.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11: qəribə (bizarre) sayıqlamalara icazə (DSM-5-TR-də də qadağa götürülüb); induksiyalı sayıqlama (folie à deux) 6A24-ə inteqrasiya edilmişdir.
- DSM-5-TR: alt-tip kvalifikatorları (erotomanik, qrandioz, qısqanclıq, persekutor, somatik, qarışıq, qeyri-spesifik); «qəribə tip» əlavə kvalifikatoru.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (ümumi və xüsusilə sayıqlama məzmunu).
2. Qohum/dost müsahibəsi — premorbid funksiya, sayıqlamanın başlanğıcı.
3. SCID-5 / MINI; PANSS / BPRS pozitiv simptom alt-şkalası.
4. Tibbi və neyroloji müayinə.
5. Toksikoloji skrininq; sensor (eşitmə, görmə) test — yaşlılarda mütləq.
6. Beyin MRT (ilk epizodda).
7. Komorbid depressiya və intihar riski qiymətləndirməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Pozuntu	**Fərqləndirici əlamətlər**
Şizofreniya (6A20)	Hallüsinasiya, dezorqanizə olunmuş nitq və neqativ simptomlar üstünlük təşkil edir; funksiyada əhəmiyyətli pozulma.
Şizoaffektiv pozuntu (6A21)	Affektiv epizod psixotik simptomların əhəmiyyətli hissəsində.

Pozuntu	Fərqləndirici əlamətlər
Bədən dismorfik pozuntu (6B21)	Görünüş əsaslı; xəstəlik şüuru dərəcəsi dəyişkən, lakin sayıqlama səviyyəsində ola bilər.
OKP — zəif xəstəlik şüuru ilə (6B20)	Eqo-distonik obsessiya əsas; sayıqlamadan fərqlənir.
Paranoid şəxsiyyət pozuntusu	Davamlı şübhəlilik şəxsiyyət xüsusiyyəti kimi; tam sayıqlama yox.
İkincili sayıqlama (6E61)	Üzvi səbəb — demensiya, beyin şişi, lupus, ensefalit.
Maddə induksiyalı (xüsusilə amfetamin, kokain)	Maddə istifadəsi və ya kəsilmə kontekstində; eliminasiyadan sonra remissiya.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PANSS / BPRS pozitiv simptom alt-şkalası; konkret sayıqlama məzmununun strukturlaşdırılmış sənədləşdirilməsi.
- Eşitmə və görmə test (yaşlılarda mütləq).
- Laborator: tam qan, tiroid, B12, qaraciyər, qlükoza, toksikoloji skrininq, sifilis, HIV, ANA (lupus), seruloplazmin (Vilson xəstəliyi).
- Beyin MRT — ilk epizod, atipik klinik, yaşlı pasiyent.
- İntihar və zorakılıq riski qiymətləndirməsi (C-SSRS, qısqanclıq sayıqlamasında xüsusilə).

8. Müalicə

1. Atipik antipsixotik aşağı dozada (risperidon 1–3 mq, olanzapin 5–10 mq, aripiprazol 5–15 mq) — birinci sıra. Sübut bazası şizofreniyadan az; pasiyentlərin müalicəyə riayəti problemli (sayıqlama məzmununa görə).
2. Pimozid tarixən erotomaniya və somatik sayıqlamada üstün hesab edilirdi (Munro A. tədqiqatları), lakin müasir təcrübədə atipiklərə nisbətən az istifadə olunur (QTc, EKPS).
3. Psixoterapiya — supportiv terapiya, terapevtik ittifaqın qurulması; KDT (sayıqlama məzmunu ilə qeyri-konfrontasion iş, alternativ izahların araşdırılması).
4. Komorbid depressiya — SSGİ.

5. Zorakılıq və ya intihar riski (xüsusilə qısqanclıq sayıqlaması) — hospitalizasiya və qeyri-iradi müalicə qanunvericilik çərçivəsində.
6. Sensor pozuntu — eşitmə cihazları və ya göz korreksiyası — yaşlı paranoid sayıqlamada bəzən köklü təsir göstərir.
7. Sosial dəstək — təcridin azaldılması; ailə psixoedukasiyası.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Qeyri-konfrontasion KDT — Sayıqlama məzmununu açıq inkar etmədən, alternativ izahları və sübutları pasiyentlə birlikdə araşdırma. Birchwood M., Trower P. tədqiqatları — şizofreniya və sayıqlama pozuntusunda təsirlidir.
2. Supportiv terapiya və terapevtik ittifaq — Pasiyentlə uzunmüddətli etibarlı münasibətin qurulması; müalicəyə riayətin gücləndirilməsi.
3. PANSS pozitiv simptom alt-şkalası — Sayıqlamanın şiddət və müdaxilə dərəcəsinin standartlaşdırılmış qiymətləndirilməsi.
4. Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası (ing. Columbia-Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) — İntihar riski — xüsusilə qısqanclıq və təqib sayıqlamalarında zorakılıq riski əlavə qiymətləndirilir.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG178 — sayıqlama pozuntusu üçün ayrıca alqoritm yox; ümumi psixoz prinsipləri.
- APA 2021 — antipsixotik birinci sıra; xəstəlik şüuru və müalicəyə riayət çətinliyi vurğulanır.
- Munro A. icmalları (Cambridge Univ Press 1999) — alt-tip-spesifik klinik məsləhət.

9. Proqnoz

- Proqnoz şizofreniyadan yaxşıdır — funksional saxlama, gec başlanğıc.
- Müalicəyə əməl etmə əsas məhdudiyyətdir.
- Qısqanclıq və somatik sayıqlama nisbətən daha çətin müalicə olunur.
- Yaşlılarda sensor korreksiyası ilə yaxşılaşma mümkündür.
- İzləmə — antipsixotik yan təsirləri, sayıqlama şiddəti, zorakılıq və intihar riski.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pasiyenti sayıqlamasının yanlışlığına inandırmaq lazımdır»

Klinik məntiq: açıq konfrontasiya terapevtik ittifaqı pozur və sayıqlamanı gücləndirə bilər; pasiyent tərəfdən «həkim də mənə qarşıdır» izah formalaşır.

Sübut: Birchwood və Trower KDT yanaşmaları — alternativ izahların pasiyentin özü tərəfindən araşdırılmasına yol verən qeyri-konfrontasion yanaşma təsirlidir.

Mif 2: «Sayıqlama pozuntusu yalnız psixoterapiya ilə müalicə oluna bilər, antipsixotik müalicə lazım deyil»

Sübut: antipsixotik birinci sıra farmakoterapiyadır; psixoterapiya tək başına kifayət deyil. APA 2021, NICE CG178.

Mif 3: «Erotomaniya yalnız qadınlarda rast gəlinir, kişilərdə müşahidə edilmir»

Sübut: erotomaniya hər iki cinsdə baş verir; kişi pasiyentlərdə daha yüksək zorakılıq riski qeydə alınmışdır (Menzies R.P. və b. Br J Psychiatry 1995).

Mif 4: «Qısqanclıq sayıqlaması „böyük sevgi“ göstəricisidir, tibbi vəziyyət deyil»

Sübut: Othello sindromu klinik psixotik vəziyyətdir, həyat yoldaşına qarşı zorakılıq və qətl riski yüksəkdir; aktiv tibbi müdaxilə tələb edir.

Mif 5: «Yaşlılarda paranoid sayıqlama „normal yaşlanma“dır»

Sübut: yaşlılarda paranoid sayıqlama tez-tez sensor məhrumiyyət (eşitmə pozuntusu) və ya erkən demensiyanın əlamətidir; müalicə oluna bilər. Eşitmə cihazı və ya göz korreksiyası bəzən əhəmiyyətli yaxşılaşma verir.

Mif 6: «Eksorsizm və ya dini müdaxilə sayıqlamanı sağaldır»

Sübut: psixotik simptomlar neyrobioloji əsaslıdır; eksorsizmə ümid etmək antipsixotik müalicəni təxirə salır.

Mif 7: «Sayıqlama pozuntusu olan pasiyenti təcrid etmək lazımdır — sosial əlaqə zərərlidir»

Sübut: sosial təcrid əksinə sayıqlamanı gücləndirir; sosial dəstək və psixoterapiya tövsiyə edilir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6A24 Deluzional pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). KR178. Yetkinlərdə psixoz və şizofreniya. 2014/2019.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Şizofreniyanın müalicəsi üzrə təcrübə rəhbərliyi, 3-cü nəşr. 2021.
5. Manro Ə. Deluzional pozuntu: paranoyya və əlaqəli xəstəliklər. Kembric: Kembric Universiteti Nəşriyyatı; 1999.
6. Perälä Y. və b. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2007;64(1):19–28.
7. Menzies R.P., Fedoroff C.P., Qrin K.M., Aykzakson K. Kişi erotomaniyasında təhlükəli davranışın proqnozlaşdırılması. «Britaniya Psixiatriya Jurnalı» (Br J Psychiatry). 1995;166(4):529–536.
8. Hauz O.D., Kapur S. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2009;35(3):549–562.
9. Trauer P., Birçvud M., Midan Ə. və b. Hökm səslərinə qarşı koqnitiv terapiya: randomizə edilmiş nəzarətli sınaq. «Britaniya Psixiatriya Jurnalı» (Br J Psychiatry). 2004;184:312–320.

XBT-11 **6A25**	**6A25 İLKİN PSİXOTİK POZUNTULARIN SİMPTOM DOMENLƏRİ** **Symptomatic manifestations of primary psychotic disorders**
XBT-10 —	XBT-10-da qarşılığı yoxdur
DSM-5-TR F29	Dəqiqləşdirilməmiş şizofreniya spektri və digər psixotik pozuntu

1. Tərif və nozologiya

6A25 XBT-11-də ilkin psixotik pozuntular qrupunun (6A20–6A24) ölçülü alt strukturdur. Həmçinin ayrı klinik nozoloji vahid deyil — diaqnozu əsas pozuntu (məsələn, 6A20 Şizofreniya) üzərinə əlavə kvalifikator kimi qoyulur. Altı simptom

sahəsinin hər biri üçün ayrıca şiddət dərəcəsi (yoxdur / yüngül / orta / ağır) qiymətləndirilir.

Konsepsiyanın əsası — psixotik pozuntuların heterojen klinik təqdimatını klassik alt-tiplər (paranoid, hebefrenik, katatonik) əvəzinə daha etibarlı və davamlı ölçü vasitəsi ilə təsvir etməkdir.

2. Tarixçə

- Bleuler «4A» simptomları (1911) və Şnayder «1-ci dərəcəli simptomlar» (1959) kateqorial yanaşmadır.
- Crow T.J. (1980) — Tip I (pozitiv simptomun üstünlük təşkil etdiyi I tip) və Tip II (neqativ dominant) konsepsiyası — dimensional yanaşmanın əsası.
- Liddle P.F. (1987) — üç dimensional faktor — reallığın təhrifi (ing. reality distortion), dezorqanizasiya (ing. disorganization), psixomotor yoxsulluq (ing. psychomotor poverty).
- DSM-5 (2013) — III Bölmə tədqiqat kateqoriyasında dimensional qiymətləndirmə təklif edilmişdir.
- XBT-11 (2019) — 6A25 rəsmi dimensional kvalifikator kimi inteqrasiya edilmişdir.

3. Altı simptom sahə

3.1 Pozitiv simptomlar

Sayıqlama, hallüsinasiya — qavrayış və düşüncə proseslərində «əlavə olunmuş» simptomlar. Şiddət: olmamasından ağır səviyyəyə qədər (pasiyentin gündəlik fəaliyyətinə təsir dərəcəsinə görə).

3.2 Neqativ simptomlar

Affektiv yastılıq, avolisiya (motivasiya itkisi), alojiya (nitq yoxsullaşması), anhedoniya, sosial geri çəkilmə. Funksional pozulmanın əsas amilidir; farmakoterapiyaya zəif cavab verir.

3.3 Depressiv simptomlar

Aşağı əhval, ümidsizlik, intihar fikirləri, psixomotor ləngləmə, anhedoniya (neqativ simptomdan fərqli olaraq emosional komponent üstünlük təşkil edir).

3.4 Manik simptomlar

Yüksək və ya əsəbi əhval, sürətli düşüncə, böyüklük ideyaları (ing. grandiose ideas), azalmış yuxu tələbi, sürətli nitq, psixomotor həyəcanlanma.

3.5 Psixomotor simptomlar

Katatonik komponentlər (mutizm, neqativizm, mumvari elastiklik, duruş pozuntusu (ing. posturing)), agitasiya, lənglәmə, stereotipiya.

3.6 Koqnitiv simptomlar

İşlək yaddaş, diqqət, icra funksiyası, emal sürəti, sosial koqnisiya. Pasiyentlərin 75–85%-ində mövcuddur; uzunmüddətli funksional səviyyəyə güclü təsir göstərir.

4. Klinik istifadə

4.1 Qiymətləndirmə vasitələri

- Pozitiv və Neqativ Sindrom Şkalası (PANSS — ing. Positive and Negative Syndrome Scale; pozitiv, neqativ və ümumi psixopatologiya altşkalaları).
- SANS / SAPS — neqativ və pozitiv simptomlar ayrı-ayrı qiymətləndirilir.
- HAM-D, MADRS — depressiv komponent.
- YMRS — manik komponent.
- Buş-Frensis Katatoniya Qiymətləndirmə Şkalası (ing. Bush-Francis Catatonia Rating Scale) — psixomotor komponentin qiymətləndirilməsi.
- MATRICS konsensus koqnitiv batareyası (MCCB — ing. MATRICS Consensus Cognitive Battery) — koqnitiv komponentin qiymətləndirilməsi.

4.2 Müalicə implikasiyaları

- Pozitiv simptomlar üstünlük təşkil etdikdə standart antipsixotiklər (D2 reseptor antaqonistləri) təyin edilir.
- Neqativ simptom dominant — atipik antipsixotiklərə üstünlük verilir (klozapin, kariprazin); amisulprid aşağı dozada; psixososial reabilitasiya.
- Depressiv komponent — əlavə terapiya kimi SSRGİ (sertralin) və ya antidepressant; intihar riskinin monitorinqi.
- Manik komponent — əhval stabilləşdiricisi (litium, valproat) əlavə terapiya kimi; şizoaffektiv pozuntu kimi yenidən nəzərdən keçirilməsi tələb olunur.
- Katatonik komponent — lorazepam testi və ya EKT.
- Koqnitiv komponent — koqnitiv remediation (Wykes 2011 meta-analiz); dəstəklənən məşğulluq (ing. supported employment) ilə birgə tətbiq edildikdə funksional səviyyəyə təsir göstərir.

5. Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 (6A25): hər sahə üçün şiddət dərəcəsi xəstəlik gedişində dəyişdiyi üçün dövri yenidən qiymətləndirmə tövsiyə edilir.
- DSM-5-TR: Section III araşdırma kateqoriyasında «həkim tərəfindən qiymətləndirilən psixoz simptomlarının şiddəti ölçüləri» (ing. Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity) — XBT-11 6A25 ilə paralel; rəsmi diaqnostik kvalifikator deyil, lakin təcrübədə istifadə oluna bilər.
- NICE CG178: dimensional qiymətləndirmə klinik yanaşma kimi tövsiyə edilir — müalicənin fərdiləşdirilməsinin əsasını təşkil edir.

6. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «6A25 ayrı pozuntudur, diaqnoz kimi qoyula bilər»

Reallıq: 6A25 ayrı klinik vahid deyil — əsas pozuntunun (6A20–6A24) kvalifikatorudur.

Mif 2: «Dimensional yanaşma kateqorial diaqnozu əvəz edir»

Reallıq: hər ikisi tamamlayıcıdır — kateqorial diaqnoz nozoloji vahidi, dimensional kvalifikator isə konkret klinik təqdimatı təsvir edir.

Mif 3: «Neqativ simptomlar antipsixotikin yan təsiridir, „həqiqi“ yox»

Reallıq: birincili neqativ simptomlar şizofreniyanın əsas xüsusiyyətidir — antipsixotikdən əvvəl də müşahidə olunur. İkincili neqativ simptomlar (sedasiya, EKPS, depressiya, pozitiv simptomların təsiri) ayrıdır və idarə oluna bilər.

7. Mənbələr

1. WHO. ICD-11. 6A25 Symptomatic manifestations of primary psychotic disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG178. 2014/2019.
4. Crow T.J. Molecular pathology of schizophrenia: more than one disease process? Br Med J 1980;280(6207):66–68.
5. Liddle P.F. The symptoms of chronic schizophrenia. A re-examination of the positive-negative dichotomy. Br J Psychiatry 1987;151:145–151.
6. Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A. PANSS. Schizophr Bull 1987;13(2):261–276.

7. Wykes T. və b. Am J Psychiatry 2011;168(5):472–485.

6A40 KATATONİYA

Katatoniya (ing. Catatonia)

XBT-11 **6A40**	**6A40 BAŞQA BİR PSİXİ POZUNTU İLƏ ƏLAQƏLİ KATATONİYA** **Catatonia associated with another mental disorder**
XBT-10 F06.1	Üzvi katatonik vəziyyət
DSM-5-TR F06.1	Başqa psixi pozuntu ilə əlaqəli katatoniya

1. Tərif və nozologiya

Katatoniya (XBT-11: 6A40 Catatonia Associated with Another Mental Disorder; 6A41 Maddələr və ya dərman vasitələri ilə induksiya olunmuş katatoniya (ing. Catatonia Induced by Substances or Medications); 6E69 Secondary Catatonia Syndrome; DSM-5-TR: F06.1 Catatonia) — psixomotor, davranış və vegetativ funksiyalarda kompleks pozulma sindromudur. Müstəqil pozuntu deyil — başqa psixiatrik və ya tibbi vəziyyət fonunda klinik sindromdur.

DSM-5-TR-də katatoniya artıq şizofreniyanın alt-tipi deyil (ləğv edilmişdir); affektiv pozuntular, neyroinkişaf pozuntuları, üzvi vəziyyətlər və maddə induksiyalı kontekstdə kodlana bilər.

2. Tarixçə

- Kahlbaum K. (1874) — «Katatoniya, yaxud gərginlik psixozu» (alm. Die Katatonie oder das Spannungsirresein) — katatoniya ayrı sindrom kimi.
- Kraepelin (1899) — katatoniya «dementia praecox» alt-tipi kimi inteqrasiya edilmişdir.
- Bleuler (1911) — şizofreniya kateqoriyasında saxlanılmışdır.
- 1970–1980-ci illər — Taylor, Fink — katatoniyanın affektiv pozuntularda da geniş yayılması yenidən təsdiqlənmişdir və ümumi sindrom kimi yenidən təsdiq.

- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — katatoniya transnozoloji sindrom kimi rəsmiləşdirilmişdir; şizofreniya alt-tipi statusu ləğv edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Psixiatrik xəstəxanada qəbul olunan pasiyentlərin 7–15%-ində katatonik simptomlar (Fink M., Taylor M.A. Catatonia 2003).
- Affektiv pozuntularda (xüsusilə bipolyar manik və depressiv epizodlarda) katatoniya yayılması ən çox rast gəlinir.
- Şizofreniyada 10–20% pasiyent gediş ərzində katatonik xüsusiyyətlər göstərir.
- Üzvi katatoniya — autoimmun ensefalit (xüsusilə anti-NMDA-R, anti-LGI1), elektrolit pozuntuları, üremik və hepatik ensefalopatiya, sepsis, neyrosifilis, neyroəzələ xəstəlikləri kontekstində müşahidə olunur.
- Neyroleptik Malign Sindromu (NMS) ilə davamlı klinik üst-üstə düşmə — bəzi tədqiqatçılar onları eyni spektrum hesab edir.

4. Etiologiya və patogenez

- GABA-ergik sistem hipofunksiyası — lorazepamın çox sürətli klinik effekti (saatlar) bunu dəstəkləyir; GABA-A reseptor disfunksiyası mərkəzi mexanizmdir.
- Dopamin disregulasiyası — neyroleptik induksiyalı katatoniya və NMS spektrumunda; antipsixotiklərin kəskin dayandırılması xolinergik və adrenergik rebound (ing. rebound) ilə müşayiət olunur.
- Qlutamatın N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptorları üzrə disregulyasiyası — autoimmun anti-NMDA-R ensefalit klassik katatonik təqdimat verir.
- Genetik amillər — affektiv pozuntularla əlaqəli yatkınlıq yaradır.

5. Klinik təzahürlər

DSM-5-TR meyarları — 12 simptomdan ən azı 3-ü:

1. Stupor — psixomotor aktivlik yoxluğu, ətrafa cavabsızlıq.
2. Katalepsiya — passiv induksiyaya qarşı duruşun saxlanılması.
3. Mumvari çeviklik — müayinəçi tərəfindən verilən duruş mum kimi saxlanılır.
4. Mutizm — nitq yoxluğu və ya əhəmiyyətli azalma.
5. Neqativizm — təlimatlara və ya xarici stimullara qarşı müxalifət.
6. Posturing — qeyri-iradi spontan duruşun saxlanılması (qravitasiyaya qarşı).

7. Manerizm — adi davranışların qəribə karikaturası.
8. Stereotipiya — qeyri-məqsədli təkrarlanan hərəkətlər.
9. Aqitasiya — xarici stimuldan asılı olmayan həyəcanlanma.
10. Qrimas (üz qırışdırma) — üz əzələlərinin ifadələri.
11. Exolaliya — başqasının nitqinin təkrarlanması.
12. Exopraksiya — başqasının hərəkətlərinin təkrarlanması.

Şiddət formaları

- Retardasiya olunmuş (stuporoz) katatoniya — hərəki azalma, mutizm üstünlük təşkil edir; halların əksəriyyətində müşahidə olunur.
- Eksitasiya olunmuş (manik) katatoniya — yüksək agitasiya, autonom pozulma, hipertermiya.
- Malign katatoniya — eksitə forma ilə hipertermiya, autonom qeyri-sabitlik, CPK yüksək, mortalitet riski — NMS ilə üst-üstə düşür; təcili tibbi vəziyyət.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR-də 12 simptomdan ≥ 3-ü; XBT-11-də müxtəlif kateqoriyalar üzrə eyni klinik əlamətlər.

6.2 Diaqnostik testlər

- Lorazepam çağırış testi: 1–2 mq IV/IM lorazepam → 10–30 dəq ərzində katatonik əlamətlərin əhəmiyyətli azalması diaqnozu təsdiqləyir (Bush G. və b. Acta Psychiatr Scand 1996).
- Buş-Frensis Katatoniya Qiymətləndirmə Şkalası (BFCRS — ing. Bush-Francis Catatonia Rating Scale) — 23 maddəlik standartlaşdırılmış şkala; ilk 14 maddə ilkin yoxlama (ing. screening) üçün (≥ 2 əlamət — pozitiv).

6.3 Etioloji axtarış (mütləq)

1. Tam qan, qaraciyər/böyrək, elektrolitlər (Na, K, Ca, Mg, P), qlükoza, ammonyak, CPK, troponin, tiroid, B12.
2. Toksikoloji skrininq.
3. Sifilis, HIV.
4. Beyin MRT.
5. EEQ — qeyri-konvulsiv status epileptikusun istisnası.

6. Lumbal punksiya — ensefalit / autoimmun ensefalit şübhəsi (anti-NMDA-R, anti-LGI1 antikorları).
7. ANA, lupus paneli.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Neyroleptik Malign Sindrom (NMS)	Antipsixotik istifadəsi tarixçəsi; hipertermiya, rigidlik, CPK çox yüksək; klinik üst-üstə düşmə — bəziləri eyni spektrum hesab edir.
Serotoninergik sindrom	Serotoninergik preparat; hiperrefleksiya, mioklonus, hipertermiya.
Qeyri-konvulsiv status epileptikus	EEQ — epileptik aktivlik.
Akinetik mutizm (frontal payın pozulması)	Beyin MRT — frontal və ya bilateral talamik patologiya.
Lokomotor pozuntular (Parkinson, distoniya)	Spesifik neyroloji əlamətlər.
Autoimmun ensefalit	Anti-NMDA-R, anti-LGI1; BOS (beyin onurğa mayesi) tapıntıları, MRT, EEQ atipik.
Hipo/hipertiroid kriz	TSH, T4.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- BFCRS — ilkin göstəricilər və izləmə.
- Yuxarıdakı laborator və instrumental müayinələr — etioloji axtarış.
- Autonom funksiya (qan təzyiqi, nəbz, bədən hərarəti, sidik çıxışı) — xüsusilə malign formada.
- Komorbid əhval pozuntusu və psixotik simptomların qiymətləndirilməsi (sonra, pasiyent danışa biləndə).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (BAP 2023, Fink-Taylor protokolu)

1. Antipsixotiklər dayandırılmalıdır — xüsusilə tipik və yüksək D2 antaqonisti (haloperidol, risperidon yüksək doza) — katatoniyanı gücləndirə bilər, malign formaya keçirə bilər.
2. Lorazepam birinci xətt terapiyasıdır — 1–2 mq IM/IV, ilkin reaksiya əsasında titrasiya; adətən effektiv doza 6–24 mq/gün; bəzi pasiyentlərdə 30+ mq tələb olunur. təxminən 70–80% pasiyent cavab verir (Sienaert P. və b. Front Psychiatry 2014 icmal).
3. EKT — refrakter hallar (lorazepama cavabsızlıq 48–72 saatda), malign katatoniya — birinci sıra, həyat xilas edən vasitədir. NICE TA59 — katatoniyada güclü tövsiyə.
4. Etioloji müalicə — paralel: əgər affektiv pozuntu fonundadırsa, əhval stabilizatoru (litium); şizofreniya kontekstində — atipik antipsixotik (klozapin və ya kvetiapin daha az riskli) lorazepamla birlikdə ehtiyatla təyin edilir.
5. Autoimmun katatoniyada — immunoterapiya (venadaxili steroidlər, venadaxili immunoqlobulin — İVİQ, plazmaferez, ikinci sıra rituksimab).
6. Dəstəkləyici müalicə — hidratasiya, qidalanma (nazogastral zond zəruridir), dərin vena trombozu (DVT) profilaktikası, dəri qulluğu, aspirasiya pnevmoniyasının profilaktikası.
7. Malign katatoniyada — ICU; aqressiv hidratasiya, dantrolen, bromokriptin, EKT.

8.2 Müalicə metodları

1. Buş-Frensis Katatoniya Qiymətləndirmə Şkalası (ing. Bush-Francis Catatonia Rating Scale, BFCRS) — 23 maddəlik şkala; ilk 14 maddə skrininq (≥ 2 pozitiv); 23 maddə şiddət. Bush G. və b. Acta Psychiatr Scand 1996.
2. Lorazepam çağırış testi — 1–2 mq IM/IV lorazepam tətbiqindən 10–30 dəq sonra katatonik əlamətlərin azalması diaqnozu təsdiqləyir və terapiya planını istiqamətləndirir. Bush G. və b. 1996.
3. Elektrokonvulsiv Terapiya (ing. Electroconvulsive Therapy, EKT) katatoniyada qızıl standart; UK EKT Review Group Lancet 2003 sübut bazası; NICE TA59. Adətən 6–12 seans, ikitərəfli hədəfləmə.
4. İmmunoterapiya (autoimmun katatoniyada) — IV metilprednizolon 1 q/gün × 5 gün → İVİQ (venadaxili immunoqlobulin) və ya plazmaferez; refrakter

hallarda rituksimab, siklofosfamid. Graus F. və b. Lancet Neurol 2016 autoimmun ensefalit protokolu.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- BAP 2023 (Britaniya Psixofarmakologiya Assosiasiyası) Katatoniya üzrə konsensus təlimatları — lorazepam birinci sıra; EKT refrakter və ya malign hallarda; antipsixotik istifadəsindən qaçınma və ya çox ehtiyatla.
- Fink M., Taylor M.A. Catatonia: A Clinician's Guide (2003) — klassik protokol; lorazepam test və yüksək doza lorazepam terapiyası.
- NICE TA59 — EKT katatoniyada açıq tövsiyə.

9. Proqnoz

- Lorazepam və/və ya EKT-yə cavab — pasiyentlərin əksəriyyətində günlər və həftələr ərzində tam bərpa baş verir.
- Etioloji pozuntu müalicə olunmasa, residiv riski yüksəkdir.
- Komplikasiyalar — uzun stupordan aspirasiya pnevmoniyası, DVT, susuzlaşma, dəri ülserləri.
- Malign katatoniya — müalicəsiz mortalitet tarixən təxminən 50%+ (bəzi seriyalarda 75–100%); müasir müalicə (benzodiazepin/EKT) ilə təxminən 10 –20%-ə enir.
- Müşahidə — etioloji pozuntu kontekstində; residiv markerlərinin tanınması.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Katatoniya şizofreniyanın alt-tipidir»

Sübut: DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — katatoniya transnozoloji sindrom kimi; şizofreniya alt-tipi statusu ləğv edilmişdir. Affektiv pozuntular kontekstində daha tez-tez rast gəlinir (Fink və Taylor 2003).

Mif 2: «Katatonik pasiyent antipsixotiklə müalicə olunmalıdır»

Sübut: antipsixotik katatoniyanı gücləndirə və malign formaya keçirə bilər. Birinci sıra — lorazepam, sonra EKT. Antipsixotik etioloji pozuntu üçün lazımdırsa, lorazepamla birlikdə ehtiyatla; atipik antipsixotiklərə üstünlük verilir (klozapin və ya kvetiapin).

Mif 3: «Katatonik pasiyent şüurunu itirib və ya komadadır»

Sübut: əksər katatonik pasiyentlər ətrafdan tam xəbərdardır — mutizm və psixomotor pozulma şüur itkisi deyil. Pasiyent epizoddan sonra hər şeyi xatırlayır. Heyətin söhbətləri pasiyentin yanında ehtiyatla aparılmalıdır.

Mif 4: «Katatoniya nadir və ya tarixdə qalmış vəziyyətdir, müasir psixiatriyada rast gəlinmir»

Sübut: psixiatrik xəstəxanada qəbul olunan pasiyentlərin 7–15%-ində katatonik simptomlar (Fink & Taylor 2003); diaqnozu isə çox vaxt qoyulmur — az tanınan sindromdur.

Mif 5: «Lorazepam yalnız sakitləşdirir, „həqiqi“ müalicə vermir»

Sübut: lorazepam katatonik sindromun əsas mexanizminə (GABA-ergik hipofunksiyaya) yönəlir; təxminən 70–80% pasiyentdə nəzərəçarpacaq dərəcədə sürətli klinik bərpa.

Mif 6: «EKT katatoniyada təhlükəlidir və köhnəlmişdir»

Sübut: EKT katatoniyada qızıl standart, NICE TA59 açıq tövsiyə; malign katatoniyada həyat xilas edir.

Mif 7: «Pasiyenti danışmağa məcbur etmək lazımdır — psixoloji maneəni qırmaq»

Sübut: mutizm bioloji mənşəlidir, psixoloji «müqavimət» deyil; tələb pasiyentin əziyyətini artırır, terapevtik fayda vermir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6A40 Katatoniya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Rocers C.P., Pollak T.Ə., Bequm N. və b. Katatoniya: demoqrafik, klinik və laborator əlaqələr. «Psixoloji Tibb» (Psychol Med). 2023 (BAP Rəhbərliyi).
4. Fink M., Teylor M.A. Katatoniya: Diaqnostika və müalicə üzrə həkimin bələdçisi. Kembric Universitet Nəşriyyatı; 2003.
5. Buş Q., Fink M., Petrides Q. və b. Katatoniya. I. Reytinq şkalası və standartlaşdırılmış müayinə. «Skandinav Psixiatriya Aktası» (Acta Psychiatr Scand). 1996;93(2):129–136.
6. Sienert P., Dhosshe D.M., Vankampfort D. və b. Katatoniyanın müalicəsinin klinik icmalı. «Sərhədlər Psixiatriyası» (Front Psychiatry). 2014;5:181.

7. Qraus F. və b. Autoimmün ensefalitin diaqnostikasına klinik yanaşma. «Lancet Nevrologiyası» (Lancet Neurol). 2016;15(4):391–404.
8. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) (NICE TA59). Elektrokonvulsiv terapiyanın istifadəsi üzrə təlimat. 2003 (yenidən baxılmış).
9. Böyük Britaniya EKT İcmal Qrupu. Elektrokonvulsiv terapiyanın depressiv və digər psixi pozuntularda effektivliyi və təhlükəsizliyi: sistematik icmal və meta-analiz. «Lancet». 2003;361(9360):799–808.

6A60–6A7Z ƏHVAL POZUNTULARI

Mood disorders

XBT-11 **6A60**	**6A60 I TİP BİPOLYAR POZUNTU** **Bipolar type I disorder**
XBT-10 F31	Bipolyar affektiv pozuntu
DSM-5-TR F31.1x	Bipolyar I tip pozuntu; cari və ya son epizod manikdir

1. Tərif və nozologiya

Bipolyar pozuntu Tip I (XBT-11: 6A60; DSM-5-TR: F31.1x) — ən azı bir manik epizodla xarakterizə edilən, çox vaxt depressiv və ya hipomanik epizodlarla növbələnən residiv pozuntudur. Bir manik epizodun mövcudluğu diaqnoz üçün kifayətdir — depressiv epizod tələb edilmir.

2. Tarixçə

- Falret J.P. (1854) — «dövri psixoz» (fr. folie circulaire); Baillarger J. (1854) — «folie à double forme».
- Kraepelin E. (1899) — «manic-depressive insanity» — şizofreniyadan (dementia praecox) ayrı vahid.
- Leonhard K. (1957) — unipolyar və bipolyar pozuntuları ilk dəfə ayırmışdır.
- DSM-III (1980) — «Bipolar Disorder» termini.
- DSM-IV / DSM-5 (2013) / XBT-11 (2019) — Tip I (tam manik epizod) və Tip II (hipomanik və major depressiv epizodlar) ayrılması təqdim edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma Tip I: təxminən 0,6–1% (Merikangas K.R. və b. Arch Gen Psychiatry 2011, WMH).
- Cins: təxminən bərabər.
- Başlanğıc: orta 20–25 yaş; ailə tarixçəsi ilə daha erkən.

- İntihar (suisid) riski: ömürlük 6–7%; ən yüksək gənc və ilk illərdə.
- Komorbidlik: təşviş pozuntuları 60%, maddə istifadəsi 40%, DDHP, şəxsiyyət pozuntuları.
- Ölüm göstəricisi əhali (populyasiya) ilə müqayisədə 2 dəfə yüksəkdir — kardiovaskulyar, intihar.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 60–85% (Smoller J.W., Finn C.T. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2003 əkiz meta-analizi).
- GWAS — 60+ risk lokusu (Mullins N. və b. Nat Genet 2021).
- Şizofreniya ilə geniş genetik üst-üstə düşmə (ing. Cross-Disorder Group 2013).
- Neyrobioloji — monoaminergik (dopamin, serotonin, noradrenalin) disregulasiya; sirkadian ritm pozulması; ikinci vasitəçi (ing. second messenger) (PI/cAMP) sistemində pozulma; mitokondrial disfunksiya.
- Risk amilləri — uşaqlıq travması, stress, yuxu pozulması, kannabis, antidepressantlarla induksiya (bipolyar yatkınlıqda).

5. Klinik təzahürlər

5.1 Manik epizod

- Anormal yüksək və ya irritabel əhval + artmış enerji ≥ 7 gün (və ya istənilən müddətdə xəstəxanaya yerləşdirmə tələb olunduqda).
- Aşağıdakılardan ≥ 3 simptom (irritabel əhvalda ≥ 4): şişirdilmiş özünəqiymət, yuxu tələbinin azalması, həddindən artıq çoxdanışanlıq, fikirlərin uçuşu, distraktivlik, məqsədyönlü fəaliyyətin artması, riskli davranışlar.
- Funksional pozulma və ya hospitalizasiya tələbi və ya psixotik xüsusiyyətlər.

5.2 Major depressiv epizod (bipolyar kontekstdə)

- Aşağı əhval və ya anhedoniya + ≥ 5 simptom × 2 həftə (DSM-5-TR).
- Bipolyar depressiv epizod atipik xüsusiyyətlərlə (hipersomniya, hiperfagiya, qurğuşun iflici (ing. leaden paralysis)) daha tez-tez müşahidə olunur — Tip II-yə bənzər.

5.3 Qarışıq xüsusiyyətlər (ing. mixed features)

DSM-5-TR-də alt-tip ləğv olunmuşdur — kvalifikator kimi: manik epizod ərzində ≥ 3 depressiv simptom və ya depressiv epizod ərzində ≥ 3 manik simptom.

5.4 Sürətli sikllşmə (rapid cycling)

≥ 4 epizod 12 ay ərzində; mənfi proqnoz göstəricisidir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11 konsensus nöqtələri)

A. Ən azı bir manik epizod (yuxarıdakı meyarlar).

B. Manik və depressiv epizodlar şizoaffektiv pozuntu, şizofreniya və ya digər psixotik pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

Depressiv və hipomanik epizodlar Tip I diaqnozu üçün tələb deyil, lakin adətən mövcud olur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: qarışıq əlamətlər (ing. mixed features) kvalifikatoru (ing. DSM-IV mixed episode ləğv edilmişdir); enerji artımı manik epizod meyarına əlavə edilib (DSM-IV-də yalnız əhval).
- XBT-11 (6A60): manik epizod sayı və cari epizodun tipinə görə alt-kvalifikatorlar; sürətli sikllşmə kvalifikator kimi.
- NICE CG185: diaqnoz strukturlaşdırılmış müsahibə və ailədən məlumat ilə dəstəklənir; antidepressantla tətiklənmiş hipomanik/manik epizod bipolyar diaqnozuna yol açır (DSM-5-TR-də meyar B kvalifikatoru ilə).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + qohum və dostlardan alınan məlumat — manik və hipomanik epizodları ailə üzvləri daha asan tanıya bilir.
2. Strukturlaşdırılmış müsahibə (SCID-5, MINI).
3. YMRS (ing. Young Mania Rating Scale), HAM-D / MADRS.
4. MDQ (ing. Mood Disorder Questionnaire) və ya HCL-32 — bipolyar skrininq (özünüqiymətləndirmə).
5. Tibbi müayinə + laborator (tiroid, qaraciyər, böyrək, qlükoza, toksikoloji); litium başlanmazdan əvvəl spesifik testlər.
6. Beyin MRT — ilk epizod psixoz və ya atipik kontekst.
7. Komorbidlik və intihar riski (C-SSRS).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Bipolyar Tip II (6A61)	Heç vaxt manik epizod olmur; hipomanik və major depressiv epizodlar müşahidə olunur.
Siklotimik pozuntu (6A62)	≥ 2 il (yeniyetmələrdə 1 il) astanaaltı əhval dəyişmələri.
Major Depressiv Pozuntu (6A70/6A71)	Manik və ya hipomanik epizod yox.
Şizoaffektiv (6A21)	Affektiv epizoddan kənar dövrlərdə psixoz davam edir.
ŞPP (6D10.x)	Emosional dəyişkənlik saatlar və günlər ərzində; identifikasiya pozuntusu.
DDHP (6A05)	Davamlı davranış modelləri, episodik deyil.
Hipertiroid	TSH-ın azalması; titrəmə, çəki itkisi, taxikardiya.
Maddə induksiyalı (stimulyant, kokain)	Maddə tarixçəsi və zamanla əlaqə.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- YMRS, HAM-D / MADRS, MDQ, HCL-32, C-SSRS.
- Litium öncəsi: tam qan, kreatinin, TSH, kalsium, EKG, hamiləlik testi.
- Valproat öncəsi: tam qan, qaraciyər funksiyası, hamiləlik testi (doğum yaşında olan qadınlarda qəti tövsiyə edilmir).
- Karbamazepin öncəsi: tam qan, qaraciyər, natriy.
- Beyin MRT — ilk psixotik epizod.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG185, CANMAT/ISBD 2018, APA, WFSBP konsensusu)

1. Kəskin manik epizod: antipsixotik (olanzapin, risperidon, kvetiapin, aripiprazol, asenapin) ± əhval stabilizatoru (litium, valproat). Kəskin agitasiyada lorazepam adjunkt.

2. Kəskin bipolyar depressiv epizod: kvetiapin və ya lurasidon (ABQİ təsdiqi — AB Qida və Dərman İdarəsi), olanzapin/fluoksetin kombinasiyası (Symbyax); litium və ya lamotrigin adjunkt. Tək antidepressant istifadəsi əks-göstərişdir — manik epizoda keçid və sürətli sikllləşmə riski.
3. Saxlama müalicəsi: litium birinci sıra preparatdır — intihar riskini azaldır (Cipriani A. və b., BMJ, 2013) (Cipriani A. BMJ 2013); valproat, kvetiapin, lamotrigin (xüsusilə depressiv komponent dominant), olanzapin isə alternativ variant kimi istifadə olunur.
4. Refrakter: klozapin; EKT.
5. Sürətli sikllləşmə: antidepresanın tədricən dayandırılması; litium və valproat kombinasiyası.
6. Psixososial müdaxilə: psixoedukasiya, KDT bipolyar üçün, şəxsiyyətlərarası və sosial ritm terapiyası (IPSRT; ing. Interpersonal and Social Rhythm Therapy), ailə-fokuslu terapiya (Miklowitz D.).
7. Müalicəyə sadiqlik və yan təsirlərin izlənməsi — litium üçün 6 aylıq TSH, kreatinin, kalsium; valproat üçün isə qaraciyər və hematoloji göstəricilər yoxlanılır.
8. Reproduktiv yaşda olan qadınlar: valproat qəti qadağandır (neyral boru qüsuru 1–2%, ümumilikdə ağır anadangəlmə qüsurlar təxminən 10%, autizm və IQ çatışmazlıq); lamotrigin və kvetiapin nisbətən təhlükəsiz hesab edilir.

8.2 Farmakoterapiya (cədvəl 8.2.1)

Sinif	Preparat	Göstəriş
Litium	Terapevtik səviyyə 0,6–1,0 mEq/L; ağırlaşmış halda 0,8–1,2	Manik, depressiv epizodlar və saxlama müalicəsi; intihar riskini azaldır.
Antikonvulsant	Valproat (1000–2000 mq), karbamazepin (400–1200 mq), lamotrigin (200 mq, titrlə)	Manik (valproat, karbamazepin), depressiv saxlama (lamotrigin).

Sinif	Preparat	Göstəriş
Atipik antipsixotik	Olanzapin, risperidon, kvetiapin, aripiprazol, asenapin, lurasidon, kariprazin	Manik, qarışıq epizodlar və saxlama müalicəsi; kvetiapin və lurasidon ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA) tərəfindən bipolyar depressiv epizod üçün təsdiqlənmişdir.
Antidepresan	Yalnız əhval stabilizatoru ilə birlikdə	Bipolyar depressiv epizodda ehtiyatla tətbiq edilir; tək başına əks-göstərişdir.

8.3 Müalicə metodikaları

1. Litium — Bipolyar pozuntuda qızıl standart; intihar riskini azaldır; ilkin göstəricilər kreatinin, TSH, kalsium, elektrokardioqramma (EKQ); terapevtik səviyyə 0,6–1,0 mEq/L; toksiklik > 1,5 mEq/L. Cipriani BMJ 2013.
2. Bipolyar üçün uyğunlaşdırılmış KDT — psixoedukasiya, erkən marker tanınması, davranış aktivasiyası, kompliyans dəstəyi. Lam D.H. və b. Arch Gen Psychiatry 2003 RKİ.
3. Şəxslərarası və Sosial Ritm Terapiyası (ing. Interpersonal and Social Rhythm Therapy, IPSRT) — Frank (Frank E.) — Bipolyar pozuntuda sirkadian ritm və şəxslərarası stress idarəsi. Frank E. və b. Arch Gen Psychiatry 2005 RKİ — saxlama fazasında residiv azalması.
4. Ailə-Fokuslu Terapiya (ing. Family-Focused Therapy, FFT) — Miklovits (Miklowitz D.) — Pasiyent ailəsi ilə birlikdə; psixoedukasiya, ünsiyyət bacarıqları, problemin həlli. Miklowitz D.J. və b. Arch Gen Psychiatry 2003;60(9):904–912.
5. Yanq Maniya Qiymətləndirmə Şkalası (ing. Young Mania Rating Scale, YMRS) — 11 maddə manik şiddət; ilkin göstəricilər və izləmə.
6. Əhval Pozuntusu Sorğusu (ing. Mood Disorder Questionnaire, MDQ) — Hirşfeld (Hirschfeld R.M.) — bipolyar spektrin ilkin aşkarlanması üçün 13 maddəlik özünüqiymətləndirmə anketidir.
7. EKT — Refrakter manik və ya depressiv epizodda, qarışıq xüsusiyyətlərdə, intihar riskində, hamiləlikdə təhlükəsiz alternativ. NICE TA59.

8.4 Mənbələr arasında fərqlər

- CANMAT/ISBD 2018 (Yatham L.N. və b. Bipolar Disord 2018): manik epizodlar üçün birinci sıra preparatlar — litium, valproat, kvetiapin, aripiprazol, asenapin, paliperidon, risperidon; bipolyar depressiv üçün — kvetiapin, lurasidon (monoterapiya və ya litium/valproat ilə əlavə terapiya kimi).
- NICE CG185: saxlama müalicəsində litium birinci sıra preparatdır; antidepresanı yalnız əhval stabilizatoru ilə.
- Cipriani A. və b. BMJ 2013 meta-analiz: litium intihar riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır (digər əhval stabilizatorlarından üstün).
- EMA və FDA xəbərdarlıqları: valproat doğum yaşında qadınlarda — neyral tüb defekti, autizm, IQ azalma.

9. Proqnoz

- Xəstəlik episodik gedişlidir; müalicə olmadıqda residiv 80–90 % təşkil edir; saxlama farmakoterapiyası ilə bu göstərici əhəmiyyətli dərəcədə azalır.
- İntihar riski yüksək (ömürlük risk 6–7 %); ilk illərdə xüsusilə.
- Kardiovaskulyar mortalitet metabolik sindrom səbəbindən artmışdır.
- Funksional bərpa orta səviyyədədir — pasiyentlərin əksəriyyəti əhəmiyyətli sosial və peşə pozulması yaşayır.
- İzləməyə əhval şkalaları, intihar riskinin qiymətləndirilməsi və metabolik göstəricilər daxildir, litium səviyyəsi, kompliyans.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Bipolyar pozuntu sadə əhval dəyişmələridir — hər kəsdə var»

Klinik məntiq: bipolyar manik epizod həm müddət (ən azı 7 gün), həm də funksional pozulma meyarına cavab verməlidir; gündəlik əhval dəyişmələrindən fərqli klinik vəziyyətdir. Manik epizod psixotik xüsusiyyətlər və xəstəxana yatımı tələb edə bilər. Sübut: Merikangas Arch Gen Psychiatry 2011.

Mif 2: «Pis tərbiyə bipolyara səbəb olur»

Sübut: irsilik 60–80 %; valideyn təcrübəsi etiologiya deyil. Smoller & Finn 2003.

Mif 3: «Bipolyar pasiyent yaradıcı şəxsiyyətdir və ya „dahiliyin əlamətidir“»

Sübut: bəzi tədqiqatlarda yaradıcılıq peşələrində bipolyar pozuntunun yayılma tezliyi bir qədər yüksəkdir (Andreasen N.C. icmalları), lakin əksər pasiyent funksional

pozulma yaşayır; «dahilik» izahı elmi əsasdan məhrumdur və müalicədən imtinaya səbəb ola bilər və müalicədən imtinaya aparır.

Mif 4: «Bipolyar pasiyentdə antidepresan həmişə kömək edir»

Sübut: NICE CG185, CANMAT — antidepressant tək başına bipolyarda əks-göstərişdir; manik epizoda keçid və sürətli sikllləşmə riski.

Mif 5: «Litium „köhnəlmiş“ və ya təhlükəli — atipik antipsixotik birinci sıra olmalıdır»

Sübut: Cipriani BMJ 2013 — litium intiharı digər əhval stabilizatorlarından əhəmiyyətli daha çox azaldır; NICE CG185 və CANMAT 2018 — saxlamada birinci sıra.

Mif 6: «Pasiyent öz əhvalını „iradi olaraq“ idarə edə bilər»

Sübut: bipolyar epizod neyrobioloji pozuntudur; iradi idarə edilmir; farmakoterapiya və ya EKT tələb olunur.

Mif 7: «Sadəcə müşahidə kifayətdir — öz-özünə keçir»

Sübut: müalicə olunmayan epizodlar uzun müddətli funksional pozulmaya səbəb olur, kardiovaskulyar mortalitet, intihar (6–7% ömürlük).

Mif 8: «Bitki preparatları («dəliot» (Hypericum perforatum) və valerian kökü) və ya omeqa-3 əhval stabilizatorunu əvəzləyir»

Sübut: St John’s Wort sitoxrom P450 induksiyası ilə əhval stabilizatorlarının səviyyəsini azaldır və manik dönüşə səbəb ola bilər; omeqa-3 yalnız mülayim əlavə təsir göstərir, əsas müalicə üsulu deyildir.

Mif 9: «Kannabis əhval stabilizatorudur»

Sübut: kannabis bipolyar pozuntunun gedişini pisləşdirir, psixoz riskini artırır, kompliyansı azaldır.

Mif 10: «Hamiləlikdə əhval stabilizatoru tam dayandırılmalıdır»

Sübut: tam dayandırma residiv riskini 2 dəfə, xəstəliyin simptomatik keçdiyi həftələrin payını isə 5 dəfə artırır, residivə qədər olan müddəti 4 dəfədən çox qısaldır (Viguera A.C. və b. Am J Psychiatry 2007). Valproat qəti qadağa, lakin lamotrigin və kvetiapin nisbi təhlükəsizdir; fərdi balans qiymətləndirilir (NICE CG192).

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A60 Bipolyar I pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnin yenidən baxılmış variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) (NICE CG185). Bipolyar pozuntu: qiymətləndirmə və idarəetmə. 2014/2020.
4. Yatham L.N., Kennedi S.H., Parikh S.V. və b. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) və Beynəlxalq Bipolyar Pozuntular Cəmiyyətinin (ISBD) 2018 təlimatları: bipolyar pozuntulu xəstələrin idarə edilməsi. «Bipolar Disorders» (Bipolar Disord). 2018;20(2):97–170.
5. Cipriani A., Hawton K., Stokton S., Geddes C.R. Əhval pozuntularında litiumun intiharın qarşısının alınmasında rolu: yenilənmiş sistematik icmal və meta-analiz. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2013;346:f3646.
6. Merikangas K.R., Cin R., He Y.P. və b. Dünya psixi sağlamlıq tədqiqatı təşəbbüsündə bipolyar spektr pozuntusunun yayılması və əlaqəli amilləri. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2011;68(3):241–251.
7. Smoller C.V., Finn K.T. Bipolyar pozuntunun ailə, əkiz və övladlığa götürmə tədqiqatları. «Amerika Tibbi Genetika Jurnalı, C hissəsi: Tibbi Genetikada Seminarlar» (Am J Med Genet C Semin Med Genet). 2003;123C(1):48–58.
8. Mullins N. və b. 40 000-dən çox bipolyar pozuntu halının genom boyu assosiasiya tədqiqatı. «Təbiət Genetikası» (Nat Genet). 2021;53(6):817–829.
9. Frank E., Kupfer D.C., Teyz M.E. və b. Bipolyar I pozuntulu şəxslərdə şəxsiyyətlərarası və sosial ritm terapiyasının iki illik nəticələri. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(9):996–1004.
10. Miklovits D.C., Corc E.L., Riçards C.A. və b. Bipolyar pozuntuda ailəyə yönəlmiş psixoedukasiyanın randomizə edilmiş tədqiqi. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2003;60(9):904–912.
11. Vigera A.K., Uitfild T., Baldessarini R.C. və b. Bipolyar pozuntulu qadınlarda hamiləlik dövründə residiv riski: əhval stabilizatorlarının dayandırılmasının prospektiv tədqiqi. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2007;164(12):1817–1824.
12. Hirşfeld R.M., Vilyams C.B., Spitser R.L. və b. Bipolyar spektr pozuntusu üçün skrininq alətinin hazırlanması və etibarlılıq yoxlanışı (validasiya): «Əhval Pozuntusu Anketi». «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2000;157(11):1873–1875.

13. Andreasen N.K. Yaradıcılıq və psixi xəstəlik: yazıçılar və onların birinci dərəcəli qohumları arasında yayılma göstəriciləri. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 1987;144(10):1288–1292.

XBT-11 **6A61**	**6A61 BİPOLYAR POZUNTU TİP II** **Bipolar type II disorder**
XBT-10 F31	Bipolyar affektiv pozuntu
DSM-5-TR F31.81	Bipolyar pozuntu, II tip

1. Tərif və nozologiya

Bipolyar pozuntu Tip II (XBT-11: 6A61; DSM-5-TR: F31.81) — ən azı bir hipomanik epizod və ən azı bir major depressiv epizodla xarakterizə olunan, lakin heç vaxt manik epizodu olmayan bipolyar pozuntu formasıdır. Tip I-dən «yüngül» forma deyil — pasiyentlər ömürlük daha çox depressiv dövr yaşayır; funksional pozulma və intihar riski Tip I ilə müqayisəli.

2. Tarixçə

- Dunner D.L., Gershon E.S., Goodwin F.K. (1976) — bipolyar pozuntunun alt növlərini ayırmağı təklif etmişdir.
- DSM-IV (1994) — Bipolyar Tip II ayrı diaqnostik kateqoriya kimi rəsmiləşdirilmişdir.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — Tip II saxlanılmışdır, «yüngül forma» kimi yanlış konsepsiyaya qarşı vurğu.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: təxminən 0,4–1,1% (Merikangas K.R. Arch Gen Psychiatry 2011 WMH).
- Cins: qadınlarda nisbətən yüksək (təxminən 1,5:1 — Tip I-dən fərqli).
- Başlanğıc: orta 20–25 yaş, çoxsaylı depressiv epizodlar adətən hipomanik epizoddan əvvəl baş verir.
- İntihar riski Tip I ilə müqayisəli (ömürlük təxminən 5–7%); daha çox depressiv dövrün olması səbəbindən.

- Komorbidlik: narahatlıq pozuntuları 60 %-dən çox, maddə istifadəsi 30–40 %, sərhəd şəxsiyyət pozuntusu.

4. Etiologiya və patogenez

- Genetik əsas Tip I ilə üst-üstə düşür — irsilik 60–80%; GWAS lokusları paralel.
- Bipolyar tip II-nin tip I-dən ayrı genetik vahid olub-olmaması mübahisəlidir — bəzi tədqiqatlarda hər iki tip eyni spektrum kimi qiymətləndirilir.
- Sirkadian ritmin pozulması və ailə tarixçəsi patogenezdə rol oynayır.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Hipomanik epizod

- Anormal yüksək və ya qıcıqlanan əhval + artmış enerji ən azı 4 gün ərzində müşahidə olunur (tip I-də ən azı 7 gün).
- Manik epizodla eyni alt-simptomlar (azalmış yuxu, diqqətin yayınması, məqsədli aktivlik artımı və s.); ≥ 3 simptom (qıcıqlanan əhval olduqda ən azı 4 simptom).
- Funksional pozulma əhəmiyyətli olmamalıdır (hipomanik epizodun tərifinə uyğun olaraq); psixotik xüsusiyyət olmamalıdır; xəstəxana yatımı tələb olunmamalıdır. Bu meyarlar müəyyən edilərsə — diaqnoz Tip I-ə dəyişir.

5.2 Major depressiv epizod

- Ən azı 2 həftə ərzində ən azı 5 simptom müşahidə olunur (aşağı əhval və/və ya anhedoniya daxil olmaqla).
- Bipolyar Tip II depressiv epizodları çox vaxt atipik xüsusiyyətlərlə — hipersomniya, hiperfagiya, ağırlıq hissi (leaden paralysis), rədd edilmə həssaslığı (ing. rejection sensitivity).
- Pasiyentlər izləmə həftələrinin 53,9 %-ində simptomatik olmuşdur; depressiv simptomlar həftələrin 50,3%-ini təşkil edir (hipomanik 1,3%, siklləşmə/qarışıq 2,3 %) — Judd L.L. və b. Arch Gen Psychiatry 2003, 86 pasiyent, orta hesabla 13,4 il izləmə müddəti; simptomların əksəriyyəti subsindromal səviyyədədir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Ən azı bir hipomanik epizod.

B. Ən azı bir major depressiv epizod.

C. Heç vaxt manik epizod olmamışdır.

D. Hipomanik və depressiv epizodlar şizoaffektiv pozuntu, şizofreniya və ya digər psixotik pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

E. Simptomlar əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma yaradır (əsasən depressiv epizoddan).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11: hipomanik epizodda funksional pozulma əhəmiyyətli olmamalıdır; antidepresan induksiyası ilə yaranan hipomanik epizod bipolyar Tip II diaqnozuna yol açır (xüsusilə davam edən və ya təkrarlanan hallarda).
- Diaqnozun qoyulmaması (hipodiaqnostika) problemi: Hirschfeld R.M. icmalları — depressiv epizodla müraciət edən pasiyentlərin təxminən 25–50%-i əslində bipolyar Tip II-dir, lakin hipomanik epizodlar ailə tərəfindən «yaxşı dövrlər» kimi qəbul edilir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Hər depressiv pasiyentdə hipomanik epizodlar üçün strukturlaşdırılmış sorğu (SCID-5 əhval modulu, MDQ, HCL-32).
2. Ailə üzvlərindən informasiya — hipomanik dövrlərin müşahidəsi vacibdir.
3. Klinik müsahibə + YMRS, HAM-D / MADRS.
4. Laborator: tiroid, qaraciyər, böyrək, toksikoloji, hamiləlik testi.
5. Komorbidlik və intihar riski qiymətləndirməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Bipolyar Tip I (6A60)	≥ 1 manik epizod (funksional pozulma və ya xəstəxanaya yerləşdirmə tələbi).
Major depressiv pozuntu (6A70/6A71)	Hipomanik epizod yoxdur.
Siklotimik (6A62)	Tam major depressiv və ya hipomanik epizodlar yox.
ŞPP (6D10.x)	Emosional dəyişkənlik saatlar; şəxsiyyətin identikliyinin pozulması; xroniki intihar fikirləri.

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
DDHP	Davamlı; episodik deyil.
Hipertiroid	TSH ölçməsi.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- SCID-5-in əhval modulu qızıl standart hesab edilir.
- MDQ (ing. Mood Disorder Questionnaire) və HCL-32 (ing. Hypomania Checklist) — skrininq.
- YMRS, HAM-D, MADRS və C-SSRS tətbiq edilir.
- Litium təyin etməzdən əvvəl: kreatinin, TSH, kalsium və elektrokardioqramma (EKQ).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG185, CANMAT/ISBD 2018)

1. Bipolyar Tip II depressiv epizod (ən sıx təqdimat):
    - Birinci sıra — kvetiapin (FDA təsdiqi) və ya kvetiapin + litium kombinasiyası. Lurasidonun FDA göstərişi yalnız bipolyar tip I depressiv epizodunda, Tip II üçün deyil; CANMAT/ISBD 2018 də Tip II depressiv epizodda birinci sıra kimi yalnız kvetiapini göstərir.
    - Lamotrigin saxlama müalicəsində və depressiv epizodların profilaktikasında birinci sıra preparatdır (tip II-də xüsusilə effektivdir).
    - Litium — saxlama və intihar azaltma.
2. Hipomanik epizod: antidepresanı kəs; əhval stabilizatoru (litium, valproat) və ya atipik antipsixotik.
3. Antidepresan istifadəsi: bipolyar Tip II-də nisbətən təhlükəsiz hesab edilirdi, lakin son tövsiyələr (CANMAT 2018) yalnız əhval stabilizatoru ilə birlikdə (manik dönüş və sürətli sikllləşmə riskini azaltmaq üçün).
4. Saxlama (saxlayıcı müalicə): lamotrigin (depressiv komponent dominant olduqda) və ya kvetiapin; litium isə intihar riskinin azaldılması üçün.
5. Psixososial: KDT, IPSRT, ailə-fokuslu terapiya, psixoedukasiya.
6. Refrakter: klozapin, EKT.
7. Hamiləlik: valproat qəti qadağa; lamotrigin və kvetiapin nisbi təhlükəsiz.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Lamotrigin — Bipolyar Tip II saxlamada və depressiv epizod profilaktikasında effektiv; titrasiyası yavaş aparılmalıdır (Stevens-Johnson sindromu riski) — başlanğıc doza 25 mq-dır, doza 2 həftə ərzində artırılır; hədəf doza 200 mq/gün-dür. Calabrese J.R. və b. J Clin Psychiatry 2003.
2. Kvetiapin ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA) tərəfindən bipolyar depressiv epizod üçün təsdiqlənmişdir; doza 300–600 mq/gün; metabolik yan təsirlər izlənilməlidir.
3. Şəxslərarası və Sosial Ritm Terapiyası (IPSRT) Frank E. və b.; bipolyar pozuntu üçün KDT sirkadian ritmin, müalicəyə sadiqliyin və residivin profilaktikasına yönəlmişdir.
4. Hipomaniya Yoxlama Siyahısı (HCL-32 — Hypomania Checklist) — Anqst (Angst J.) — 32 maddəlik özünüqiymətləndirmə hipomanik epizod skrininqi.
5. Əhval Pozuntusu Sorğusu (ing. Mood Disorder Questionnaire, MDQ) — 13 maddə; bipolyar skrininq.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- CANMAT/ISBD 2018: Tip II depressiv epizod birinci sıra — kvetiapin; lamotrigin saxlamada.
- NICE CG185: Tip I və II üçün əsas yanaşma eynidir, lakin Tip II-də lamotriginin xüsusi rolu vurğulanır.
- Calabrese J.R. RKİ-ləri — lamotriginin bipolyar spektrdə saxlayıcı effekti (əsas sübut tip I pasiyentlərində alınmışdır).

9. Proqnoz

- Episodik gediş; saxlama farmakoterapiyası ilə residiv əhəmiyyətli azalır.
- Tip II Tip I-dən «yüngül» deyil — yüksək funksional pozulma və depressiv yük.
- İntihar riski yüksəkdir.
- Kvetiapin və lamotrigin saxlamada əsas.
- İzləmə — depressiv simptomlar, hipomanik tətikləyicilər, metabolik göstəricilər.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Tip II bipolyar „yüngül forma“dır, müalicəyə az ehtiyac var»

Sübut: Judd L.L. Arch Gen Psychiatry 2003 — Tip II pasiyentlər müşahidə həftələrinin 50,3%-ini depressiv simptomlarla keçirmişdir (ümumi simptomatik dövr 53,9 %); funksional pozulma və intihar riski Tip I ilə müqayisəli.

Mif 2: «Hipomanik epizod „yaxşı dövrdür“, müalicəyə ehtiyac yoxdur»

Sübut: hipomanik epizod riskli davranışa, münasibətlərin pozulmasına, sonradan məhsuldarlığın azalmasına səbəb ola bilər və depressiv epizodu törədə bilər; ayrı-ayrı epizodlar saxlama farmakoterapiyasının zəruriliyini göstərir.

Mif 3: «Tip II pasiyentdə antidepressant tək başına istifadə edilə bilər»

Sübut: CANMAT 2018 — antidepressant yalnız əhval stabilizatoru ilə; manik dönüş və sürətli sikllləşmə riski.

Mif 4: «Bipolyar Tip II yalnız sərhəd şəxsiyyət pozuntusunun bir formasıdır»

Sübut: əhəmiyyətli üst-üstə düşmə və komorbidlik var, lakin bunlar ayrı pozuntulardır; bipolyar Tip II episodik, ŞPP davamlı model.

Mif 5: «Lamotrigin manik epizodun müalicəsində effektivdir»

Sübut: lamotrigin depressiv komponentdə və saxlamada effektivdir; manik epizod üçün effektsizdir — bu halda antipsixotik və ya valproat tələb olunur.

Mif 6: «Dəliot təbii antidepresan olduğu üçün bipolyar pozuntuda təhlükəsizdir»

Sübut: St John’s Wort manik dönüşə səbəb ola bilər və əhval stabilizatorlarının səviyyəsini azaldır (sitoxrom P450 (CYP) induksiyası); bipolyarda əks-göstərişdir.

Mif 7: «Tip II-də EKT lazım deyil»

Sübut: refrakter depressiv epizod və ya yüksək intihar riskində elektrokonvulsiv terapiya (EKT) göstərişdir; Tip II pasiyentdə də effektiv.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A61 Bipolyar II pozuntu. 2024.

2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnin yenidən baxılmış variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) (NICE CG185). Bipolyar pozuntu: qiymətləndirmə və idarəetmə. 2014/2020.
4. Yatham L.N. və b. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) və Beynəlxalq Bipolyar Pozuntular Cəmiyyətinin (ISBD) 2018 təlimatları. «Bipolar Disorders» (Bipolar Disord). 2018;20(2):97–170.
5. Cudd L.L., Akiskal H.S., Şettler P.C. və b. Bipolyar II pozuntunun uzunmüddətli həftəlik simptomatik statusunun təbii tarixçəsinin prospektiv tədqiqi. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2003;60(3):261–269.
6. Kalabrese C.R. və b. Yeni depressiyaya düşmüş bipolyar I pozuntulu xəstələrdə lamotrigin və litiumla dəstək müalicəsinin plasebo nəzarətli 18 aylıq tədqiqi. «Klinik Psixiatriya Jurnalı» (J Clin Psychiatry). 2003;64(9):1013–1024.
7. Cipriani A. və b. Əhval pozuntularında litiumun intiharın qarşısının alınmasında rolu: yenilənmiş sistematik icmal və meta-analiz. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2013;346:f3646.
8. Merikangas K.R. və b. Dünya psixi sağlamlıq tədqiqatı təşəbbüsündə bipolyar spektr pozuntusunun yayılması və əlaqəli amilləri. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2011;68(3):241–251.
9. Anqst C. və b. HCL-32: hipomanik simptomlar üçün özünüqiymətləndirmə aləti istiqamətində. «Təsir Pozuntuları Jurnalı» (J Affect Disord). 2005;88(2):217–233.
10. Hirşfeld R.M., Vilyams C.B., Spitser R.L. və b. Bipolyar spektr pozuntusu üçün skrininq alətinin hazırlanması və etibarlılıq yoxlanışı: «Əhval Pozuntusu Anketi». «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2000;157(11):1873–1875.
11. Frank E., Kupfer D.C., Teyz M.E. və b. Bipolyar I pozuntulu şəxslərdə şəxsiyyətlərarası və sosial ritm terapiyasının iki illik nəticələri. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(9):996–1004.

XBT-11 **6A62**	**6A62 SİKLOTİMİK POZUNTU** **Cyclothymic disorder**
XBT-10 F34.0	Siklotimiya
DSM-5-TR F34.0	Siklotimik pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Siklotimik pozuntu (XBT-11: 6A62; DSM-5-TR: F34.0 — siklotimik pozuntu (ing. cyclothymic disorder)) — ən azı 2 il (yetkinlərdə; uşaq/yeniyetmələrdə 1 il) ərzində astanaaltı hipomanik və depressiv simptomların davamlı dəyişməsi ilə xarakterizə olunan xronik affektiv pozuntudur. Tam major depressiv, manik və ya hipomanik epizodlara çatmır.

2. Tarixçə

- Kahlbaum K. (1882) — «siklotimiya» terminini təqdim etmişdir.
- Kraepelin (1899) — manik-depressiv pozuntunun yüngül forması.
- Akiskal H.S. (1977) — siklotimik temperamenti bipolyar spektrumun alt mərhələsi kimi yenidən müəyyənləşdirmişdir.
- DSM-III (1980), DSM-5 (2013), XBT-11 (2019) siklotimik pozuntu affektiv pozuntular kateqoriyasına aid edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 0,4–1% (DSM-5-TR; geniş diapazon, dəqiq epidemioloji məlumat məhduddur).
- Cins: təxminən bərabər.
- Başlanğıc: yeniyetməlik və erkən yetkinlik.
- Tip I və ya II bipolyara konversiya: təxminən 15–50% (Akiskal H.S. icmalları).
- Komorbidlik: narahatlıq, maddə istifadəsi, DDHP, sərhəd şəxsiyyət pozuntusu.

4. Etiologiya və patogenez

- Bipolyar spektr ilə ortaq genetik yük müəyyən edilmişdir (Akiskal H.S.).
- Ailə tarixçəsində bipolyar və major depressiv pozuntu tezliyi artmışdır.
- Neyrobioloji — bipolyar pozuntudakı kimi monoaminergik və sirkadian disregulyasiya, lakin daha az ifadə edilmiş.

5. Klinik təzahürlər

- Çoxsaylı astanaaltı hipomanik dövrlər qısa və zəif ifadə olunmuş enerji və əhval yüksəlmələri ilə xarakterizə olunur.
- Çoxsaylı astanaaltı depressiv dövrlər — az intensiv depressiv simptomlar.
- «Stabil dövr» 2 aydan az.
- Əhval dəyişmələri günlər və ya həftələr; pasiyent öz vəziyyətini «mənim təbiətim belədir» şəklində xarakterizə edə bilər.
- Şəxslərarası və peşə pozulması ortadır, ancaq dağıdıcı deyil.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11)

A. Ən azı 2 il (yetkinlər) / 1 il (uşaq/yeniyetmələr) ərzində çoxsaylı hipomanik və depressiv astanaaltı dövrlər.

B. Bu müddət ərzində simptomlar zamanın ≥ yarısında mövcuddur və simptomsuz dövr 2 aydan çox deyil.

C. Tam major depressiv, manik və ya hipomanik epizod meyarlarına heç vaxt cavab verilməmişdir.

D. Şizoaffektiv, şizofreniya və ya digər psixotik pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

E. Maddə və ya tibbi vəziyyət istisnası.

F. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

6.2 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (əhval gündəliyi 4–6 həftə tövsiyə edilir — pasiyentin əhval dəyişmələrinin qanunauyğunluqlarının sənədləşdirilməsi).
2. SCID-5, MDQ, HCL-32.
3. Komorbidlik və ailə tarixçəsi qiymətləndirməsi.
4. Tibbi və laborator (tiroid mütləq).

6.3 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Bipolyar Tip II (6A61)	Tam hipomanik və major depressiv epizodlar.
Distimik pozuntu (6A72)	Yalnız depressiv astanaaltı; hipomanik dövrlər yoxdur.
ŞPP (6D10.x)	Saat-saatlıq əhval dəyişmələri; identifikasiya pozuntusu; impulsivlik və münasibətlər.
DDHP (6A05)	Episodik deyil; diqqət defisiti dominant.
Siklotimik temperament (ing. normal variant)	Funksional pozulma yoxdur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Əhval gündəliyi.
- MDQ, HCL-32, YMRS, HAM-D.
- tiroid funksiyası.

8. Müalicə

1. Psixoterapiya birinci sıra müalicə üsuludur — KDT, IPSRT, psixoedukasiya, davranış aktivasiyası, sirkadian ritmin idarə edilməsi.
2. Farmakoterapiya — sübut bazası məhduddur:
    - Litium və ya valproat — bipolyar spektr kontekstində adekvat hesab olunur.
    - Lamotrigin — depressiv komponent üstünlük təşkil etdikdə tətbiq edilir.
    - Atipik antipsixotik (kvetiapin) orta və ağır hallarda tətbiq edilir.
3. Antidepressant tək başına — manik epizoda keçid və sürətli siklləşmə riski yaradır; əks-göstərişdir.
4. Stress idarəsi və sosial-sirkadian ritmin saxlanması vacibdir.
5. Bipolyar pozuntuya keçidin izlənməsi — ailə tarixçəsi və klinik markerlər varsa daha sıx izləmə.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Şəxslərarası və Sosial Ritm Terapiyası (IPSRT) — Frank (Frank E.) — Sirkadian ritm və şəxslərarası stress idarəsi.
2. Bipolyar spektr üçün KDT — psixoedukasiya, davranış aktivasiyası, residiv markerləri.
3. Əhval gündəliyi pasiyentin öz əhval dəyişmələrinin sənədləşdirilməsi diaqnostik və terapevtik vasitədir.
4. Litium və lamotrigin — bipolyar spektrin farmakoterapiyası üçün adekvat vasitələrdir.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG185, CANMAT 2018 — siklotimik pozuntu üçün ayrıca alqoritm məhduddur; bipolyar spektrin prinsipləri tətbiq olunur; psixoterapiya birinci sıra üsulu kimi tövsiyə olunur.

9. Proqnoz

- Xronik; spontan remissiya nadir.
- bipolyar tip I/II-yə konversiya riski — illik klinik qiymətləndirmə tələb olunur.
- Komorbid maddə istifadəsi və ŞPP risk amilləri.
- Adekvat müalicə ilə funksional səviyyə yaxşılaşır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Siklotimik temperament normal şəxsiyyət xüsusiyyətidir, müalicə tələb etmir»

Klinik məntiq: siklotimik temperament normal variant olduqda funksional pozulma yoxdur; klinik diaqnoz funksional pozulma tələb edir. Lakin bir çox pasiyent illərlə «yaradıcı təbiət» kimi izah edir və müdaxiləyə müraciət etmir, halbuki həyat keyfiyyəti pisləşir.

Mif 2: «Siklotimik pozuntu bipolyara çevrilməyəcək»

Sübut: Akiskal — 15–50% bipolyar Tip I və ya II-yə konversiya; ailə tarixçəsi varsa daha yüksək risk mövcuddur.

Mif 3: «Antidepresan tək başına bütün əhval dəyişmələrini idarə edər»

Sübut: manik epizoda keçid və sürətli siklləşmə riski; əhval stabilizatoru ilə birlikdə müalicə tələb olunur.

Mif 4: «Siklotimik pasiyent yaradıcılığını müalicəyə görə itirəcək»

Sübut: uyğun müalicə (psixoterapiya + əhval stabilizatoru) yaradıcılığı saxlamağa və artırmağa yardım edir (stabilləşdirici fəaliyyət); romantikləşdirilmiş «dahilik» izahı müdaxilədən yayınmağa aparır.

Mif 5: «Bitki preparatları və ya pəhriz siklotimik pozuntunu sağaldır»

Sübut: Dazıotu (St John's wort) manik epizoda keçid riski yaradır; omega-3 mülayim adjunkt, əsas müalicə deyil.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A62 Siklotimik pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Diaqnostik və Statistik Təlimat, 5-ci nəşr, mətnin yenidən baxılmış variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik təlimat CG185. 2014/2020.
4. Yatam L.N. və b. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) / Beynəlxalq Bipolyar Pozuntular Cəmiyyəti (ISBD) 2018 klinik təlimatları. «Bipolyar Pozuntular» (Bipolar Disord). 2018;20(2):97–170.
5. Akiskal H.S., Xani M.K., Skott-Strauss A. Siklotimik temperament pozuntuları. «Şimali Amerika Psixiatriya Klinikaları» (Psychiatr Clin North Am). 1979;2(3):527–554.
6. Frank E., Kupfer D.C., Teys M.E. və b. Bipolar I pozuntusu olan şəxslərdə şəxsiyyətlərarası və sosial ritm terapiyasının ikiillik nəticələri. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(9):996–1004.

XBT-11 **6A70**	**6A70 TƏK EPİZODLU DEPRESSİV POZUNTU** **Single episode depressive disorder**
XBT-10 F32	Depressiv epizod
DSM-5-TR F32.x	Böyük depressiv pozuntu, tək epizod

1. Tərif və nozologiya

Tək epizodlu depressiv pozuntu (ing. XBT-11: 6A70 Single Episode Depressive Disorder; DSM-5-TR: Major Depressive Disorder, Single Episode, F32.x) — ən azı 2 həftə ərzində aşağı əhval və/və ya anhedoniya ilə birlikdə əhəmiyyətli koqnitiv, somatik və psixomotor simptomların müşayiət olunduğu, funksional pozulma yaradan affektiv pozuntudur. Pasiyentin tarixçəsində yalnız bir böyük depressiv epizod müşahidə olunur (residiv halında 6A71 kodlanır).

2. Tarixçə

- Hippokrat (e.ə. V–IV əsrlər) — «melanxoliya» termini.
- Kraepelin (1899) — «manik-depressiv psixoz» çərçivəsində depressiv epizod.
- DSM-III (1980) — «Böyük depressiv pozuntu» rəsmi diaqnoz kimi qəbul edilmişdir; bipolyar pozuntudan ayrılma.
- DSM-5 (2013) — «yas istisnası» ləğv olunmuşdur — pasiyent yaxınını itirdikdən sonra da böyük depressiv epizod diaqnozu qoyula bilər.
- XBT-11 (2019) — Tək epizodlu (6A70) və Təkrarlanan (6A71) ayrı kodlanır.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 15–20% (NESARC-III; Hasin D.S. və b. JAMA Psychiatry 2018).
- İllik yayılma: təxminən 6–8%.
- Cins: qadınlarda 1,5–2 dəfə daha yüksəkdir.
- Başlanğıc: orta 20–30 yaş; lakin istənilən yaşda mümkündür.
- İntihar: depressiv pozuntu intihar ölümlərinin təxminən 50%-i ilə əlaqəli.
- Komorbidlik: təşviş pozuntuları 60%, maddə istifadəsi 25%, ağrı, kardiovaskulyar, diabet.
- Ölüm göstəricisi: ümumi ölüm 1,5 dəfə yüksəkdir (kardiovaskulyar, intihar).

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 35–40% (Sullivan P.F. və b. Am J Psychiatry 2000 meta-analiz); bipolyar pozuntuya nisbətən azdır.
- GWAS — 100+ risk lokusu (Howard D.M. və b. Nat Neurosci 2019, n>800 000).

- Neyrobioloji — monoaminergik (serotonin, noradrenalin, dopamin) hipotezi; hipotalamo-hipofiz-adrenal (HPA) oxunun disregulasiyası, kortizol səviyyəsinin yüksəlməsi; hipokampın həcminin azalması; inflamasiya hipotezi (CRP, IL-6).
- Risk amilləri: uşaqlıq travması, ailə tarixçəsi, kəskin stress, xronik tibbi xəstəlik, sosial təcrid, maddə istifadəsi, doğum sonrası dövr, hipotiroid.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Əsas simptomlar (DSM-5-TR — ≥ 5 simptom 2 həftə ərzində; ən azı biri aşağı əhval və ya anhedoniya olmalıdır)

1. Davamlı aşağı əhval.
2. Anhedoniya — maraq və zövqün itirilməsi.
3. Çəki və ya iştah dəyişmələri.
4. Yuxu pozulması (insomniya və ya hipersomniya).
5. Psixomotor agitasiya və ya ləngləmə (başqaları tərəfindən müşahidə oluna bilən).
6. Yorğunluq və ya enerji itkisi.
7. Dəyərsizlik və ya hədsiz günah hissi.
8. Konsentrasiya çətinliyi və qərar qəbul etmə pozulması.
9. İntihar fikirləri və ya plan.

5.2 Kvalifikatorlar (DSM-5-TR)

- Şiddət: yüngül, orta, ağır.
- Psixotik xüsusiyyətlərlə (sayıqlama və ya hallüsinasiya).
- Atipik xüsusiyyətlər (hipersomniya, hiperfagiya, «qurğuşun iflici» (leaden paralysis)).
- Melanxolik xüsusiyyətlər.
- Katatonik xüsusiyyətlər.
- Peripartum başlanğıc.
- Mövsümi gediş (seasonal pattern).
- Qarışıq xüsusiyyətlər (ing. mixed features, manik komponentlərlə).
- Narahatlıqla.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11 konsensus nöqtələri)

A. Yuxarıdakı 5 və daha çox simptom ≥ 2 həftə; ən azı biri aşağı əhval və ya anhedoniya.

B. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

C. Maddə və ya tibbi vəziyyət istisnası.

D. Heç vaxt manik və ya hipomanik epizod olmamışdır.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: «yas istisnası» ləğv edilmişdir (DSM-IV-də yas dövründə 2 ay diaqnoz qoyulmurdu); yas və depressiv epizod birgə baş verə bilər.
- XBT-11 (6A70): tək epizod ayrı kod; şiddət və psixotik xüsusiyyət kvalifikatorları.
- NICE NG222 (2022): şiddət təsnifatı: daha yüngül, daha ağır (DSM-də yüngül/orta/ağır əvəzinə); müalicə şiddətə görə alqoritmlər əsasında qurulur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Strukturlaşdırılmış müsahibə (SCID-5, MINI).
3. Şkalalar — PHQ-9 (skrininq və izləmə), HAM-D, MADRS, BDI-II.
4. İntihar riski (C-SSRS).
5. Bipolyar skrininq (MDQ, HCL-32) — bipolyar epizodları istisna etmək.
6. Tibbi və laborator (tiroid, B12, folat, ferritin, qaraciyər, böyrək, hamiləlik) — somatik səbəbi istisna.
7. Toksikoloji skrininq (maddə istifadəsi şübhəsi).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Bipolyar tip I/II (6A60/6A61)	Manik və ya hipomanik epizod tarixçəsi.
Distimik pozuntu (6A72)	ən azı 2 il ərzində astana altı depressiv simptomlar müşahidə olunur.
Uyğunlaşma pozuntusu (6B43)	Stress amilinə cavab; meyar sayı azdır.

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Yas (kədər)	Yaxın şəxsin itkisindən sonra; «dalğa-dalğa» gediş; özünə qiymət saxlanılır.
Hipotireoz	TSH yüksək; somatik simptomlar.
B12 / folat çatışmazlığı	Laborator.
Maddə ilə induksiya olunmuş depressiya	Maddə istifadəsi tarixçəsi.
Demensiyada depressiv simptomlar	Koqnitiv çatışmazlıq dominant; yaşlı pasiyent.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PHQ-9 — ilkin tibbi yardımda standart; ≥ 10 bal orta-ağır depressiyaya uyğundur.
- HAM-D-17 (Hamilton), MADRS — klinik və tədqiqat praktikasında.
- BDI-II — özünüqiymətləndirmə.
- C-SSRS — intihar riski.
- Laborator: tam qan, tiroid, B12, folat, ferritin, qaraciyər/böyrək, qlükoza.
- EKG — TCA (trisiklik antidepresanlar) və ya QT intervalını uzadan preparatlar başlanmazdan əvvəl çəkilməlidir.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE NG222, APA 2010, CANMAT 2016 konsensusu)

1. Şiddətə görə pillə-pillə yanaşma:
    - Yüngül (PHQ-9 5–9) — rəhbərlik altında özünəyardım (ing. guided self-help), koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) əsaslı internet müdaxilələri, fiziki aktivlik, müşahidə.
    - Orta (PHQ-9 10–14) — KDT və ya İPT və ya farmakoterapiya (SSGİ); pasiyent seçimi.
    - Orta-ağır (PHQ-9 15–19) — farmakoterapiya (SSGİ) və ya yüksək intensivlikli psixoloji müdaxilə; üstünlük kombinasiyaya verilir.
    - Ağır (PHQ-9 ≥ 20 və ya psixotik xüsusiyyətlər) — farmakoterapiya və psixoterapiya kombinasiyası; ağır psixotik / intihar riski — hospitalizasiya və EKT.

2. Birinci sıra farmakoterapiya: SSGİ — sertralin, essitalopram, fluoksetin, paroksetin, sitalopram. Təsir 4–6 həftə ərzində görünür; dozanın tədricən artırılması tələb olunur.
3. SNGİ — venlafaksin, duloksetin — alternativ və ya komorbid ağrı/narahatlıq.
4. Digər — mirtazapin (yuxu və iştah problemləri), bupropion (cinsi yan təsiri azdır, DDHP komorbidliyi olduqda), agomelatin, vortioksetin (koqnitiv komponent).
5. Refrakter hallarda: SSGİ və lityum və ya kvetiapin və ya aripiprazol; SSGİ kombinasiyaları; ketamin/esketamin (intranazal — FDA təsdiqi 2019, ağır refrakter); EKT.
6. Psixoterapiya birinci sıra alternativ — yüngül-orta depressiyada monoterapiya, ağır halda farmakoterapiya ilə kombinasiya; konkret metodlar və sübut bazası «Müalicə metodikaları» bölməsində (KDT, İPT, davranış aktivasiyası, MBCT).
7. İntihar riskinin idarə edilməsi — aktiv qiymətləndirmə; risk yüksəkdirsə hospitalizasiya; vasitələrə (silah, dərman) məhdudlaşdırılmış əlçatanlıq; psixososial dəstək.
8. Müalicə müddəti: ilk epizodda remissiyadan sonra 6–12 ay davam; rezidiv hallarda uzunmüddətli.

8.2 Farmakoterapiya

Sinif	Preparat	Doza diapazonu	Qeyd
SSGİ	Sertralin, esitalopram, fluoksetin, paroksetin, sitalopram	Sertralin 50–200 mq; esitalopram 10–20 mq	Birinci sıra; cinsi yan təsir; SIADH (yaşlılarda); sitalopram > 40 mq QT uzanması.
SNGİ	Venlafaksin, duloksetin	Venlafaksin 75–375 mq; duloksetin 60–120 mq	Komorbid ağrı, təşviş.
Atipik	Mirtazapin, bupropion, agomelatin, vortioksetin	Mirtazapin 15–45 mq; bupropion 150–450 mq	Mirtazapin yuxu və iştah; bupropionun cinsi yan təsiri yoxdur.

Sinif	Preparat	Doza diapazonu	Qeyd
TCA	Amitriptilin, nortriptilin	75–150 mq	İkinci–üçüncü sıra; kardial və antikolinergik yan təsirlər; doza aşılması öldürücüdür.
MAOİ	Fenelzin, tranilsipromin	—	Refrakter; tiramin pəhrizi.
Esketamin (intranazal)	Spravato	56–84 mq	FDA 2019, refrakter; klinikada nəzarət altında.

8.3 Müalicə metodikaları

1. Depressiya üçün KDT — Bek (Beck A.) — Koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, davranış aktivasiyası; 12–20 seans. Sübut: Cuijpers P. və b. Cochrane meta-analizləri — orta effekt, farmakoterapiya ilə müqayisəli; kombinasiya monoterapiyadan üstün ağır halda.
2. Şəxslərarası Terapiya (İPT / IPT — Interpersonal Therapy) — Klerman (Klerman G.), Vaysman (Weissman M.) — 4 problem sahəsi — yas, rol keçidi, rol konflikti, şəxslərarası çatışmazlıq. 12–16 seans. randomizə olunmuş klinik tədqiqatlarda (RKİ) KDT ilə müqayisəli effekt.
3. Davranış Aktivasiyası (ing. Behavioral Activation) — Ceykobson (Jacobson N.), Martell (Martell C.) — Müsbət fəaliyyətlərin sistematik artırılması, qaçınmanın azaldılması. Dimidjian S. və b. J Consult Clin Psychol 2006 RKİ — KDT-yə müqayisəli effekt.
4. Mayndfulnes əsaslı koqnitiv terapiya (MBCT — şüurlu diqqət-Based Cognitive Therapy) — Seqal (Segal Z.), Williams (Williams M.), Tisdel (Teasdale J.) — Residiv profilaktikasında; xüsusilə ≥ 3 epizod tarixçəsi varsa effekti antidepresan müalicəsini saxlamadan üstün ola bilər (Kuyken W. və b. Lancet 2015).
5. Pasiyent Sağlamlıq Sorğusu-9 (ing. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) — Kroenke (Kroenke K.), Spitser (Spitzer R.L.) — Birinci tibbi yardımda qızıl standart skrininq və izləmə vasitəsi.
6. HAM-D / MADRS — həkim tərəfindən qiymətləndirilən depressiya şiddəti şkalaları.

7. EKT — Ağır psixotik depressiya, refrakter, intihar riski, qida qəbulu pozulması, hamiləlik. UK EKT Review Group Lancet 2003 — Ağır hallarda EKT farmakoterapiyadan üstündür.
8. Esketamin / Ketamin — FDA 2019 intranazal esketamin (Spravato) ağır refrakter depressiya üçün; sürətli antidepressant effekt (saatlar və günlər ərzində); klinikada nəzarət altında tətbiq. Daly E.J. və b. JAMA Psychiatry 2018.
9. Təkrarlanan Transkranial Maqnit Stimulyasiyası (ing. rTMS — repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) — Refrakter depressiyada FDA təsdiqi (2008); 4–6 həftə kursu, sol dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) hədəfi.

8.4 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG222 (2022): şiddətə görə pillə-pillə alqoritm; «daha yüngül» — KDT və ya rəhbərlik altında özünəyardım birinci sıra; «daha ağır» halda — kombinasiya.
- APA Practice Guideline (2010, 2019 yenilənmə): SSGİ birinci sıra; KDT / İPT birinci sıra alternativ.
- CANMAT 2016: şiddət və gediş əsasında 4 pilləli alqoritm.
- Cipriani A. və b. Lancet 2018 network meta-analiz: 21 antidepressant müqayisəsi — agomelatin, mirtazapin, paroksetin, venlafaksin və vortioksetin ən yüksək effekt; fluoksetin, fluvoksamin, reboxetin və trazodon ən aşağı. Uyğunlaşmada (acceptability) ən yaxşılar — agomelatin, sitalopram, esitalopram, fluoksetin, sertralin, vortioksetin; reboxetin isə həm effektə, həm uyğunlaşmaya görə ən aşağıdadır. Effekt fərqləri klinik baxımdan mülayimdir.

9. Proqnoz

- Spontan remissiya 50% bir ildə (lakin əksər remissiya antidepressant dəstəyi olmadan); residiv riski yüksək.
- Hər sonrakı epizoddan sonra növbəti epizod riski artır.
- Suicid riski xüsusilə ilk həftələrdə yüksəkdir.
- İzləmə — PHQ-9 / MADRS, intihar riski, yan təsirlər, müalicəyə uyğunluq; ilk 12 həftə daha sıx.
- Müalicə müddəti — ilk epizodda remissiyadan sonra 6–12 ay.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Depressiya — sadəcə „kədər“; iradi olaraq aradan qaldırılır»

Sübut: depressiya kompleks neyrobioloji pozuntudur — HPA disregulasiyası, monoamin disbalansı, struktur dəyişikliklər (hippokamp); «iradi» idarə edilmir. APA, ÜST və NICE depressiyanı tibbi xəstəlik kimi qəbul edir.

Mif 2: «Antidepresan asılılıq yaradır»

Sübut: SSGİ və SNGİ asılılıq (addiction) yaratmır — nə sui-istifadəyə, nə də toleransa səbəb olmur. Lakin kəsmə sindromu mövcuddur (xüsusilə qısa yarımömrü paroksetin, venlafaksin) — bu asılılıq deyil, fizioloji uyğunlaşma; tədricən kəsmə ilə həll olunur.

Mif 3: «Antidepresan pasiyentin şəxsiyyətini dəyişdirir»

Sübut: antidepressant simptomları azaldır, şəxsiyyəti dəyişmir. Pasiyent «özümü hiss etmirəm» deyə şikayət edirsə — yan təsir (emosional düzləşmə, emotional blunting) — preparatın dəyişdirilməsi və ya dozanın azaldılması tələb olunur.

Mif 4: «Antidepresanlar plasebodan üstün deyil»

Sübut: Cipriani Lancet 2018 — 21 antidepresan preparat plasebodan əhəmiyyətli üstündür; lakin effekt mülayimdir, xüsusilə yüngül depressiyada. Orta-ağır depressiyada effekt klinik baxımdan əhəmiyyətlidir.

Mif 5: «Pəhriz (omega-3, B vitaminləri, magnezium) antidepressantı əvəzləyir»

Sübut: bəzi əlavələrin (omega-3, vitamin D çatışmazlığı olduqda) mülayim adjunkt effekti ola bilər, lakin orta-ağır depressiyada əsas müalicəni əvəzləmir. SMILES tədqiqatı (Jacka F.N. BMC Med 2017) — Aralıq dənizi tipli pəhriz mülayim əlavə təsir göstərir.

Mif 6: «Dazıotu (St John’s wort) təbii antidepresandır, antidepresanı əvəzləyə bilər»

Sübut: St John’s Wort yüngül depressiyada effekt göstərir (Cochrane Linde K. 2008), lakin orta-ağır depressiyada sübut bazası məhduddur; sitokrom P450 (CYP) induksiyası ilə bir çox preparatın (kontraseptiv, antikoagulant, antidepressant, antiretroviral) səviyyəsini azaldır — ciddi qarşılıqlı təsir.

Mif 7: «Yalnız idman və ya psixoterapiya kifayətdir, dərman lazımsızdır»

Sübut: yüngül depressiyada psixoterapiya və idman bəzən kifayətdir, lakin orta-ağır depressiyada və xüsusilə intihar riskində farmakoterapiya zəruridir; NICE NG222 və APA 2010 təlimatları bunu təsdiqləyir.

Mif 8: «EKT köhnəlmiş və ya travmatik müalicədir»

Sübut: müasir EKT (anesteziya altında, əzələ relaksantları ilə) təhlükəsiz və yüksək effektivdir; ağır refrakter və psixotik depressiyada qızıl standart. UK EKT Review Group Lancet 2003.

Mif 9: «Antidepresanlar intihar yaradır»

Sübut: FDA-nın «qara qutu» xəbərdarlığı uşaq və yeniyetmələrdə (xüsusilə ilk həftələrdə) İntihar fikirlərinin artması riski — bu, ilk həftələrdə klinik izləmə tələbidir, lakin uzunmüddətli effektdə antidepressantlar intihar riskini azaldır (Stone M. və b. BMJ 2009).

Mif 10: «Yas dövründə depressiya diaqnozu qoyula bilməz»

Sübut: DSM-5 «yas istisnası»nı ləğv etmişdir; yas və major depressiv epizod birgə baş verə bilər; yasın patoloji formaları (uzanmış yas pozuntu — 6B42) ayrıdır.

Mif 11: «Depressiya psixoloji „zəiflik“ əlamətidir»

Sübut: depressiya istənilən şəxsdə baş verə bilər; «psixoloji güc» konsepsiyası stigmatik və yanlışdır; tibbi vəziyyət kimi qiymətləndirilməlidir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A70 Tək epizodlu depressiv pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Diaqnostik və Statistik Təlimat, 5-ci nəşr, mətnin yenidən baxılmış variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG222. Yetkinlərdə depressiya: müalicə və idarəetmə. 2022.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Böyük Depressiv Pozuntu ilə Xəstələrin Müalicəsi üzrə Təcrübə Təlimatı. 3-cü nəşr. 2010.
5. Kennedi S.H., Lam R.V., Makintayr R.S. və b. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) 2016 Böyük Depressiv Pozuntusu Olan Yetkinlərin İdarə Edilməsi üzrə Klinik Təlimatları. «Kanada Psixiatriya Jurnalı» (Can J Psychiatry). 2016;61(9):540–560.

6. Çipriani A., Furukava T.A., Salanti Q. və b. Yetkinlərdə böyük depressiv pozuntunun kəskin müalicəsi üçün 21 antidepressant preparatın müqayisəli effektivliyi və məqbulluğu: sistematik icmal və şəbəkə meta-analizi. «Lancet». 2018;391(10128):1357–1366.
7. Hasin D.S., Sarvet A.L., Mayers C.L. və b. ABŞ-da yetkinlərdə DSM-5 böyük depressiv pozuntusunun və onun təyinedicilərinin epidemiologiyası. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2018;75(4):336–346.
8. Hovard D.M. və b. Depressiyanın genom üzrə meta-analizi 102 müstəqil variantı aşkar edir. «Nature Neuroscience» (Nat Neurosci). 2019;22(3):343–352.
9. Kuypers P., Karyotaki E. de Vit L., Ebert D.D. Yetkin depressiyası üçün on beş sübuta əsaslanan terapiyanın təsirləri: meta-analitik icmal. «Psixoterapiya Tədqiqatları» (Psychother Res). 2020;30(3):279–293.
10. Kuyken V., Hayes R., Barrett B. və b. Depressiv residivin qarşısının alınmasında zehinlilik əsaslı koqnitiv terapiyanın davamlı antidepressant müalicəsi ilə müqayisədə effektivliyi və xərc-səmərəliliyi. «Lancet». 2015;386(9988):63–73.
11. Kroenke K., Spitser R.L., Vilyams C.B. PHQ-9: depressiya ağırlığının qısa ölçüsünün etibarlılığı. «Ümumi Daxili Tibb Jurnalı» (J Gen Intern Med). 2001;16(9):606–613.
12. Daly E.C. və b. Müalicəyə davamlı depressiyada oral antidepressant terapiyasına əlavə kimi intranazal esketaminin effektivliyi və təhlükəsizliyi. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2018;75(2):139–148.
13. Caka F.N. və b. Böyük depressiyası olan yetkinlər üçün pəhrizin yaxşılaşdırılmasının randomizə edilmiş nəzarətli sınağı («SMILES» sınağı). «BMC Tibb» (BMC Med). 2017;15(1):23.
14. Böyük Britaniya Elektrokonvulsiv Terapiya İcmal Qrupu (ing. UK ECT Review Group). «Lancet». 2003;361(9360):799–808.
15. Stone M., Laughren T., Cons M.L. və b. Yetkinlərdə antidepressantların klinik sınaqlarında intihar riski: ABŞ Qida və Dərman İdarəsinə (FDA) təqdim edilmiş şirkətlərə məxsus məlumatların təhlili. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2009;339:b2880.
16. Bek A.T., Raş A.C., Şou B.F., Emeri Q. Depressiyanın koqnitiv terapiyası. Nyu York: Guilford Nəşriyyatı; 1979.
17. Martell K.R., Dimiciyan S., Herman-Dann R. Depressiya üçün davranış aktivasiyası: həkim üçün bələdçi. Nyu York: Guilford Nəşriyyatı; 2010.
18. Vaysman M.M., Markovits C.K., Klerman Q.L. Şəxsiyyətlərarası psixoterapiya üzrə hərtərəfli bələdçi. Nyu York: Basic Books Nəşriyyatı; 2000.

19. Segal Z.V., Vilyams C.M.Q., Tizdeyl C.D. Depressiya üçün zehinlilik əsaslı koqnitiv terapiya. 2-ci nəşr. Nyu York: Guilford Nəşriyyatı; 2013.
20. Ceykobson N.S., Dobson K.S., Truaks P.A. və b. Depressiyanın koqnitiv-davranış müalicəsinin komponent təhlili. «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 1996;64(2):295–304.

XBT-11 **6A71**	**6A71 TƏKRARLANAN DEPRESSİV POZUNTU** **Recurrent depressive disorder**
XBT-10 F33	Qayıdan depressiv pozuntu
DSM-5-TR F33.x	Böyük depressiv pozuntu, təkrarlanan

1. Tərif və nozologiya

Təkrarlanan depressiv pozuntu (ing. XBT-11: 6A71 Recurrent Depressive Disorder; DSM-5-TR: Major Depressive Disorder, Recurrent, F33.x) — ən azı iki böyük depressiv epizodun mövcudluğu ilə xarakterizə olunur, epizodlar arasında 2 aydan az davam etməyən qismən və ya tam remissiya. Manik və ya hipomanik epizod tarixçəsi yoxdur (varsa diaqnoz bipolyar pozuntudur).

Tək epizodlu depressiv pozuntudan (6A70) yalnız epizod sayı ilə fərqlənir; klinik təzahürlər, diaqnostik meyarlar və müalicə prinsipləri eynidir, lakin uzunmüddətli saxlama farmakoterapiyasının rolu burada daha vacibdir.

2. Tarixçə

- Kraepelin (1899) — manik-depressiv pozuntu çərçivəsində residiv depressiv epizodlar.
- Leonhard K. (1957) unipolyar depressiya konsepsiyasını irəli sürmüşdür.
- DSM-III (1980), DSM-5 (2013) — Major Depressive Disorder, Recurrent rəsmi diaqnoz kimi təsbit edilmişdir.
- XBT-11 (2019) — Tək (6A70) və Təkrarlanan (6A71) ayrı kodlanır.

3. Epidemiologiya

- Böyük depressiv pozuntunun ömürlük yayılması 15–20% təşkil edir; bunun təxminən 50–80%-i residiv gediş.
- Hər sonrakı epizoddan sonra növbəti epizod riski artır (Solomon D.A. və b. Am J Psychiatry 2000) — 1-ci epizoddan sonra təxminən 50%, 2-ci sonra təxminən 70%, 3-cü sonra təxminən 90%.
- İntihar riski tək epizodlu pozuntuya nisbətən daha yüksəkdir, xüsusilə müalicəsiz epizodlarda.

4. Etiologiya və patogenez

- Tək epizodlu (6A70) ilə eyni — irsilik təxminən 35–40% (Sullivan 2000); GWAS lokusları.
- Residiv predisposisiya — daha çox koqnitiv yatkınlıq, neyrobioloji «alışma» (kindling) konsepsiyası — hər epizoddan sonra növbəti epizod üçün astana azalır.
- Risk amilləri — uşaqlıq travması, ailə tarixçəsi, xronik stress, komorbid narahatlıq, somatik xəstəliklər.

5. Klinik təzahürlər

Tək epizodla eyni (bax 6A70 §5). Residiv pasiyentlərdə əlavə xüsusiyyətlər:

- Epizod təzahürləri əvvəlki epizodlardan dəyişə bilər (atipik xüsusiyyətlər, mövsümi model).
- Residiv epizodlar tipik olaraq əvvəlkilərdən daha tez başlayır (kindling konsepsiyası — Post R.M. Am J Psychiatry 1992).
- Komorbid təşviş pozuntuları artan tezliklə müşahidə olunur.
- Xronik koqnitiv çatışmazlıq müşahidə oluna bilər (xüsusən çoxsaylı epizoddan sonra).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11)

A. Ən azı 2 major depressiv epizod (6A70 §6.1 meyarlarına uyğun).

B. Epizodlar arasında ≥ 2 ay qismən və ya tam remissiya.

C. Heç vaxt manik və ya hipomanik epizod olmamışdır.

D. Şizoaffektiv pozuntu, şizofreniya və ya digər psixotik pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11: hazırkı epizod şiddəti (yüngül, orta, ağır) və psixotik xüsusiyyət kvalifikatorları; remissiya statusu (qismən, tam).
- DSM-5-TR: kvalifikatorlar 6A70 ilə eyni.
- NICE NG222: ≥ 3 epizod olan pasiyentlərdə MBCT (Mayndfulnes əsaslı koqnitiv terapiya; şüurlu diqqət-based cognitive therapy) residiv profilaktikası üçün xüsusi tövsiyə olunur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Tarixçə — əvvəlki epizodların sayı, müddət, tətikləyicilər, remissiya keyfiyyəti.
2. Bipolyar skrininq (MDQ, HCL-32) hipomanik epizodları istisna etmək üçün aparılır.
3. PHQ-9 / HAM-D / MADRS — hazırkı epizod şiddəti.
4. C-SSRS — intihar riski (residiv pasiyentlərdə yüksək).
5. Laborator (tiroid, B12, folat, ferritin); somatik komorbidliyin qiymətləndirilməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

6A70 ilə eyni (bax tək epizod). Bipolyar epizodları istisna etmək üçün xüsusi diqqət tələb olunur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

Bu pozuntu 6A70 ilə eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Xüsusi diqqət koqnitiv defisitlərin qiymətləndirilməsinə yetirilməlidir (çoxsaylı epizoddan sonra).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE NG222, APA 2010, CANMAT 2016)

1. Kəskin epizodun müalicəsi 6A70-də olduğu kimidir (SSGİ, KDT, kombinasiya).
2. Saxlama farmakoterapiyası uzunmüddətlidir:
    - 2 epizoddan sonra — remissiyadan sonra 1–2 il davam.

- ≥ 3 epizoddan sonra saxlama uzunmüddətli (illərlə) və ya ömürlük aparılır.
- Effektiv olan antidepressant remissiyadan sonra eyni dozada saxlanılır (doza azaldılması residiv riskini artırır).

3. MBCT — diqqətlilik (ing. mindfulness) əsaslı koqnitiv terapiya — ≥ 3 epizod tarixçəsi olan pasiyentlərdə residiv profilaktikasında antidepressant saxlama ilə müqayisəli effekt (Kuyken W. və b. Lancet 2015).
4. Litiumun əlavə tətbiqi (adjunktiv terapiya) refrakter və ya yüksək residiv riski olan pasiyentlərdə göstərilir; intihar azaltma effekti (Cipriani BMJ 2013).
5. Residiv markerlərinin tanınması — pasiyent və ailə üçün psixoedukasiya (yuxu pozulması, əsəbilik (irritabellik), sosial geri çəkilmə, anhedoniya).
6. Komorbidlik müalicəsi — təşviş pozuntuları, maddə istifadəsi, kardiovaskulyar — paralel.
7. İntihar riski yüksəkdir, xüsusilə yeni epizodun başlanğıcında; pasiyent izlənilməlidir.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Diqqətlilik əsaslı koqnitiv terapiya (MBCT) — 8 həftəlik qrup proqramı; 2,5 saatlıq seans və ev praktikası. Residiv profilaktikasında ≥ 3 epizod tarixçəsi olan pasiyentlərdə effektiv. Kuyken W. və b. Lancet 2015 RKİ. mbct.com.
2. Antidepresanlarla saxlama müalicəsi — Eyni preparat və doza ilə uzunmüddətli istifadə; ən az 2 il (≥ 3 epizoddan sonra); kəsmə zamanı tədricən (4–8 həftə).
3. KDT və İPT saxlama formaları — Ayda bir və ya hər 2 həftədən bir seans; residiv profilaktikası.
4. Litium adjunkt — Yüksək intihar riski olan refrakter unipolyar depressiyada; Cipriani BMJ 2013.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG222 (2022): ≥ 3 epizod tarixçəsi varsa — MBCT və ya antidepresanla saxlama; hər iki variant müqayisə oluna bilən effektivliyə malikdir.
- APA 2010-a görə saxlama farmakoterapiyası ≥ 2 epizoddan sonra başlanır, ≥ 3 epizoddan sonra isə uzunmüddətli aparılır.
- Geddes J.R. və b. Lancet 2003 meta-analiz: antidepresanla saxlama residivin azaldılmasında placebodan əhəmiyyətli dərəcədə üstündür (NNT 5).

9. Proqnoz

- Residiv riski hər epizoddan sonra artır (Solomon 2000).
- Adekvat saxlama müalicəsi ilə residiv riski əhəmiyyətli azalır (NNT 5).
- Komorbid narahatlıq, somatik xəstəliklər, kompliyans pozulması — əlverişsiz proqnoz.
- Nəzarət — PHQ-9 şkalası ilə dövri qiymətləndirmə; residiv markerləri; antidepresanın qan səviyyəsi və yan təsirləri; intihar riski.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Antidepresan ömürlük istifadə edilə bilməz, „asılılıq“ yaradır»

Sübut: SSGİ/SNGİ asılılıq yaratmırlar; ≥ 3 epizod tarixçəsi olan pasiyentlər üçün ömürlük saxlama tövsiyə edilir (NICE NG222, APA 2010). Saxlama dozasının azaldılması residiv riskini artırır.

Mif 2: «Remisyadan sonra antidepressantı dərhal kəsmək lazımdır»

Sübut: remissiyadan sonra ən azı 6–12 ay (tək epizod) və ya illər (residiv) davam edilir; erkən kəsmə residiv riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır (Geddes Lancet 2003).

Mif 3: «Hər epizodda preparat dəyişdirilməlidir»

Sübut: əvvəlki epizodda effektiv olan preparat növbəti epizodda da tətbiq edilməlidir (pasiyentə xas effektivlik).

Mif 4: «Təkrarlanan depressiv pozuntu „şəxsiyyət zəifliyi“dir, müalicə uzun olmamalıdır»

Sübut: neyrobioloji «alışma» (kindling) konsepsiyası — hər epizod yeni epizod riskini artırır; uzunmüddətli müalicə neyrobioloji zədələnmənin qarşısını alır.

Mif 5: «Yalnız MBCT residiv profilaktikası üçün kifayətdir, farmakoterapiya lazımsızdır»

Sübut: Kuyken Lancet 2015 — MBCT və antidepressant saxlama müqayisəli; lakin seçim pasiyentin dəyərləri, müalicənin əlçatanlığı və əvvəlki müalicəyə cavabı əsasında fərdi qaydada aparılır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A71 Təkrarlanan depressiv pozuntu. 2024.

2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Diaqnostik və Statistik Təlimat, 5-ci nəşr, mətnin yenidən baxılmış variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG222. 2022.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Böyük Depressiv Pozuntu (TDP) üzrə Təcrübə Təlimatı. 3-cü nəşr. 2010.
5. Kennedi S.H. və b. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) 2016. «Kanada Psixiatriya Jurnalı» (Can J Psychiatry). 2016;61(9):540–560.
6. Solomon D.A. və b. Böyük depressiv pozuntunun çoxsaylı təkrarlanmaları. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2000;157(2):229–233.
7. Post R.M. Psixososial stressin təkrarlanan affektiv pozuntunun neyrobiologiyasına transduksiyası. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 1992;149(8):999–1010.
8. Geddes C.R. və b. Depressiv pozuntularda antidepressiv dərman müalicəsi ilə residivin qarşısının alınması: sistemli icmal. «Lancet». 2003;361(9358):653–661.
9. Kuyken V. və b. «Lancet». 2015;386(9988):63–73.
10. Çipriani A. və b. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2013;346:f3646.

XBT-11 **6A72**	**6A72 DİSTİMİK POZUNTU** **Dysthymic disorder**
XBT-10 F34.1	Distimiya
DSM-5-TR F34.1	Davamlı depressiv pozuntu (distimiya)

1. Tərif və nozologiya

Distimik pozuntu (XBT-11: 6A72 Distimik pozuntu; DSM-5-TR: davamlı depressiv pozuntu — XBT-10: F34.1) — ən azı 2 il (yetkinlərdə; uşaqlarda və yeniyetmələrdə 1 il) ərzində davam edən, major depressiv epizodun şiddətinə çatmayan xronik depressiv simptomlarla xarakterizə olunan pozuntudur. Pasiyent öz halını «həmişə belə olmuşam» kimi izah edə bilər.

DSM-5-TR-də «davamlı depressiv pozuntu» (Persistent Depressive Disorder) termini distimiya və xronik major depressiv pozuntunu birləşdirir; XBT-11-də distimik və xronik depressiv epizod ayrı kodlanır.

2. Tarixçə

- Flemming C.F. (1844) — «distimiya» termininin psixiatriyada ilk istifadəsi; Kahlbaum (1882) — termini xroniki, subsindromal depressiv vəziyyət kimi müasir mənada işlətmişdir.
- Akiskal H.S. (1980-ci illər) — distimik temperamenti depressiv spektrumun alt mərhələsi kimi qiymətləndirmişdir.
- DSM-III (1980) — «Distimik pozuntu» rəsmi diaqnoz kimi qəbul edilmişdir.
- DSM-5 (2013) — «Persistent Depressive Disorder» — distimiya və xronik TDP birləşdirilməsi.
- XBT-11 (2019) — distimik pozuntu ayrı saxlanılmışdır.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 1,1–6,4% (distimiya); ABŞ-da 12 aylıq yayılma təxminən 0,5%, xroniki major depressiya üçün əlavə 1,5% (DSM-5-TR).
- Cins: qadınlarda 2 dəfə yüksək.
- Başlanğıc: erkən (uşaqlıq və ya yeniyetməlik dövrü — erkən başlanğıc; 21 yaşdan sonra — gec başlanğıc).
- «İkili depressiya» (double depression) — distimik pozuntu fonunda major depressiv epizod — 76,9% pasiyentdə 5 il ərzində baş verir (Klein D.N. və b. Am J Psychiatry 2000;157(6):931–939).
- Komorbidlik: narahatlıq, ŞPP, maddə istifadəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- Major depressiv pozuntu ilə paylaşılan genetik və neyrobioloji yatkınlıq.
- Uşaqlıq travması və xronik psixososial stress əsas mühit risk amilləri hesab edilir.
- Yaxın qohumlarda depressiv pozuntu və ya distimiya tezliyi daha yüksəkdir.

5. Klinik təzahürlər

- Davamlı aşağı əhval — günün böyük hissəsində, günlərin əksəriyyətində mövcuddur (vaxtın ≥ yarısı, 2 il ərzində 2 aydan çox simptomsuz dövr yoxdur).
- Aşağıdakılardan ən azı 2-si: aşağı və ya yüksək iştah, insomniya və ya hipersomniya, aşağı enerji, aşağı özünəqiymət, konsentrasiya çətinliyi, ümidsizlik.
- Pasiyent çoxsaylı funksional məhdudiyyətlərə uyğunlaşmışdır — «həmişə belə olmuşam» izahatı tipikdir; klinikaya çox vaxt major depressiv epizod fonunda müraciət edir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Depressiv əhval ən azı 2 il (uşaqlarda və yeniyetmələrdə ən azı 1 il) ərzində günün böyük hissəsində, günlərin əksəriyyətində davam edir.

B. Depressiv dövrlərdə 5-ci bölmədə sadalanan simptomlardan ən azı 2-si müşahidə olunur.

C. 2 il (1 il) ərzində 2 aydan çox simptomsuz dövr yoxdur.

D. Bu müddət ərzində major depressiv epizod meyarları müttəsil mövcud ola bilər (DSM-5 — yeni «ikili depressiya» sintezi).

E. Heç vaxt manik və ya hipomanik epizod olmamışdır.

F. Şizoaffektiv və ya digər psixotik pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

G. Simptomlar maddə istifadəsi və ya digər tibbi vəziyyətlə daha yaxşı izah olunmur.

H. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: «Persistent Depressive Disorder» — distimiya + xronik TDP birləşdirilmiş; kvalifikatorlar — erkən/gec başlanğıc (ing. early/late onset), with/without anxious əzab-əziyyət, melanxolik, atipik, peripartum, mövsümi və s.
- XBT-11: distimik pozuntu (6A72) ayrı; xronik depressiv epizod 6A70/6A71 daxilində kvalifikator kimi verilir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və uzunmüddətli tarixçənin toplanması (pasiyent dəqiq başlanğıcı xatırlamaya bilər).
2. SCID-5; PHQ-9, HAM-D, MADRS.
3. Bipolyar skrininq.
4. Şəxsiyyət qiymətləndirməsi — ŞPP ilə differensial.
5. Tibbi və laborator (tiroid, anemiya, B12).

6.4 Differensial diaqnostika (cədvəl 1)

Vəziyyət	**Fərqləndirici əlamətlər**
Major depressiv pozuntu (6A70/6A71)	Diskret epizodlar; epizodlar arasında əhval normal olur.
Siklotimik pozuntu (6A62)	Hipomanik dövrlər mövcud.
ŞPP (6D10.x)	Emosional dəyişkənlik saatlar ərzində; şəxsiyyət identikliyinin pozulması.
Uyğunlaşma pozuntusu (6B43)	Stress amilinə cavab; ≤ 6 ay.
Hipotiroid	TSH.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PHQ-9, HAM-D, MADRS.
- Kornell distimiya qiymətləndirmə şkalası (ing. Cornell Dysthymia Rating Scale) — distimiyaya xas.
- Tibbi və laboratoriya müayinələri.

8. Müalicə

1. Farmakoterapiya: SSGİ (sertralin, fluoksetin) — birinci sıra; effekt 6–8 həftədən sonra görünə bilər (major depressiv epizoddakından daha gec).
2. Psixoterapiya: CBASP (ing. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy — McCullough J.) — xüsusi olaraq xronik depressiya üçün hazırlanmışdır; KDT, İPT.
3. Kombinasiya — distimik pozuntuda monoterapiyadan üstün (Keller M.B. və b. NEJM 2000 — nefazodon + CBASP RKİ).
4. «İkili depressiya»da — kəskin epizod major depressiv epizod kimi müalicə edilir və uzunmüddətli saxlama aparılır.

5. Refrakter — preparatın dəyişdirilməsi, gücləndirmə (litium, atipik antipsixotik).

8.1 Müalicə metodikaları

1. Psixoterapiyanın Koqnitiv-Davranış Analiz Sistemi (ing. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP) — Makkalou (McCullough J.) — Xronik depressiya üçün xüsusi hazırlanmış yanaşma — situasiya analizi, şəxslərarası davranış öyrətmə, terapevtik münasibətin əsas vasitə kimi istifadəsi. Keller M.B. və b. NEJM 2000 RKİ.
2. SSGİ-lər uzunmüddətli tətbiq edilir: sertralin, fluoksetin, essitalopram; cavab gec formalaşır, saxlama uzun aparılır.
3. KDT və İPT — Standart depressiv terapiyalar; xronik formada modifikasiyalı.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG222 — xroniki depressiv simptomlar üçün uzunmüddətli koqnitiv-davranış müalicəsi tövsiyə edilir (bələdçidə CBASP adı çəkilmir); CBASP-ı adı ilə tövsiyə edən mənbə — APA 2010.
- APA 2010-a görə kombinasiya müalicəsi üstündür.
- Keller M.B. və b. NEJM 2000 — nefazodon + CBASP kombinasiyası monoterapiyadan əhəmiyyətli dərəcədə üstün.

9. Proqnoz

- Xronik gediş; spontan remissiya azdır.
- «İkili depressiya» — distimiyası olan və əvvəl major epizod keçirməmiş pasiyentlərin 76,9%-də 5 il ərzində inkişaf edir (Klein D.N. və b. Am J Psychiatry 2000).
- Uzunmüddətli müalicə ilə funksional səviyyə yaxşılaşır.
- Nəzarət — dövri şkala qiymətləndirmələri, müalicəyə əməl etmə, komorbidlik.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Distimiya yalnız „qəmli xarakter“dir, tibbi pozuntu deyil»

Sübut: davamlı funksional pozulma, intihar riski, «ikili depressiya» inkişafı; tibbi pozuntu kimi qiymətləndirilməlidir.

Mif 2: «Distimik pasiyent antidepressanta cavab verməz»

Sübut: cavab ləngdir (6–8 həftə), lakin SSGİ-lər effektivdir; CBASP ilə kombinasiya üstün.

Mif 3: «Xronik depressiya yalnız psixoterapiya tələb edir, dərmanlar təsirsizdir»

Sübut: Keller NEJM 2000 — nefazodon + CBASP kombinasiyası monoterapiyadan üstün; farmakoterapiya əsas komponentdir.

Mif 4: «Pasiyentin „həmişə belə olmuşam“ izahı diaqnozu istisna edir»

Sübut: bu pasiyent baxışı diaqnozun qoyulmaması problemini yaradır — uzunmüddətli funksional kompromis tibbi vəziyyət markeri ola bilər.

Mif 5: «Bitki preparatları distimik üçün təhlükəsiz alternativdir»

Sübut: Dəlibəng (St John’s wort, Hypericum perforatum) yüngül depressiyada müəyyən effekt göstərir, lakin CYP induksiyası ilə qarşılıqlı təsir yaradır; standart antidepresanlar daha üstündür.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6A72 Distimik pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) NG222. 2022.
4. Keller M.B., Makkalou C.P., Kleyn D.N. və b. Nefazodonun, psixoterapiyanın koqnitiv-davranış analizi sisteminin və onların kombinasiyasının xroniki depressiyanın müalicəsində müqayisəsi. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2000;342(20):1462–1470.
5. Kleyn D.N., Şankman S.A., Rouz S. Distimik pozuntu və ikiqat depressiyanın təbii gedişatının onillik prospektiv izləmə tədqiqatı. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2006;163(5):872–880.
6. Makkalou C.P. Xroniki depressiyanın müalicəsi: Psixoterapiyanın koqnitiv-davranış analizi sistemi. Guilford Nəşriyyatı (ing. Guilford Press); 2000.

XBT-11 **GA34.41**	**GA34.41 PREMENSTRUAL DİSFORİK POZUNTU (PMDP)** **Premenstrual dysphoric disorder**
XBT-10 N94.3	Menstruasiya qabağı gərginlik sindromu
DSM-5-TR N94.3	Premenstrual disforik pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Premenstrual Disforik Pozuntu (XBT-11: GA34.41; DSM-5-TR: 625.4 / XBT-10: N94.3) — menstrual sikldən əvvəlki son həftədə (luteal faza) əhəmiyyətli emosional və davranış simptomları, menstruasiya başladıqdan sonra bir neçə gün ərzində tam keçən, təkrarlanan pozuntudur. premenstrual sindromdan (PMS) klinik şiddət və funksional pozulma ilə fərqlənir.

2. Tarixçə

- Frank R.T. (1931) — «premenstrual gərginlik» (premenstrual tension) termini işlədilmişdir.
- DSM-IV (1994) — «premenstrual disforik pozuntu» DSM-IV-in III bölməsində tədqiqat kateqoriyası kimi verilmişdir.
- DSM-5 (2013) — depressiv pozuntular kateqoriyasında rəsmi diaqnoz olaraq qəbul edilmişdir.
- XBT-11 (2019) — əhval pozuntuları daxilində ayrı kateqoriya kimi.

3. Epidemiologiya

- Reproduktiv yaşda qadınlarda yayılma: 3–8% (Yonkers K.A. və b. Lancet 2008 icmal).
- PMS yüngül forma olub qadınların 30–80%-də müşahidə olunur.
- Komorbidlik: major depressiv pozuntu, narahatlıq pozuntusu, bipolyar pozuntu — bu pozuntular PMDP riskini artırır.
- İntihar fikirləri luteal fazada əhəmiyyətli dərəcədə artır.

4. Etiologiya və patogenez

- Genetik: irsilik təxminən 30–50% (Treloar S.A. və b. Psychol Med 2002 əkiz tədqiqatları).
- Hormonal həssaslıq: PMDP pasiyentlərində ovarial hormonlar (estrogen, progesteron) normal səviyyədədir; lakin həssaslıq artmışdır — allopregnanolon (progesteron metaboliti) GABA-A reseptorlarına anormal təsir göstərir (Schmidt P.J. və b. NEJM 1998, ovarial supressiya və hormon əlavəsi tədqiqatı).
- Serotoninergik disregulasiya: SSGİ-lərin sürətli effekti (1–2 gün, klassik depressiyadan fərqli olaraq) bu mexanizmi dəstəkləyir.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Affektiv və davranış simptomları (luteal fazada)

- Affektiv labillik (kəskin dəyişən əhval, ağlamağa meyillilik, rədd edilməyə həssaslıq (ing. rejection sensitivity)).
- İrritabellik və qəzəb partlayışları (şəxslərarası konflikt).
- Aşağı əhval, ümidsizlik, özünə tənqid.
- Narahatlıq, gərginlik.

5.2 Davranış və somatik simptomları

- Adi fəaliyyətlərdə maraq azalması.
- Konsentrasiya çətinliyi.
- Letarji və yorğunluq.
- İştah dəyişməsi (xüsusilə karbohidrat ehtiyacı), həddindən artıq yemək (hiperfagiya).
- Yuxu pozulması (insomniya və ya hipersomniya).
- Nəzarət itkisi hissi.
- Somatik — bədənin şişməsi, bel ağrısı, baş ağrısı, döşlərin həssaslığı.

5.3 Müddət və ritm

Simptomlar luteal fazada (menses öncəsi 1 həftə) başlayır, menses başladıqdan sonra bir neçə gün ərzində tam keçir; follikulyar fazada (menses sonrası) tam remissiya.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, XBT-11)

A. Əksər menstrual sikllərdə luteal fazanın son həftəsində ən azı 5 simptom; menses başladıqdan sonra bir neçə gün ərzində azalır; postmenstrual fazada tam remissiya.

B. Aşağıdakılardan ən azı 1-i:

1. Affektiv labillik;
2. İrritabellik və ya qəzəb;
3. Aşağı əhval və ya özünə tənqid;
4. Narahatlıq və gərginlik.

C. Aşağıdakılardan ən azı 1 əlavə simptom (B və C üzrə cəmi ən azı 5 simptom):

5. Maraq azalması;
6. Konsentrasiya çətinliyi;
7. Letarji, yorğunluq;
8. İştah dəyişməsi, həddindən artıq yemək;
9. Yuxu pozulması;
10. Nəzarət itkisi hissi;
11. Somatik (şişmə, ağrı və s.).

D. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

E. Diaqnozun təsdiqi üçün ən azı 2 sikl ərzində prospektiv əhval gündəliyi aparılması məcburidir.

F. Başqa psixiatrik pozuntunun (TDP, panik, distimik) simptom artımı deyil (PMDP ayrı diaqnozdur; lakin bu pozuntular fonunda da baş verə bilər — «premenstrual exacerbation»).

6.2 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə — sikl-bağlı simptomların ritmi.
2. Prospektiv əhval gündəliyi 2 sikl — DRSP (ing. Daily Record of Severity of Problems, Endicott J.) və ya PRISM (ing. Premenstrual Record of Impact and Severity of Menstruation) — diaqnozu retrospektiv tarixçədə təsdiqləmək olmaz.
3. Komorbidliyin skrininqi (depressiv pozuntu, narahatlıq pozuntusu, bipolyar pozuntu).
4. Tibbi (tiroid, anemiya, polikistik yumurtalıq sindromu).

6.3 Differensial diaqnostika (cədvəl 2)

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
PMS (premenstrual sindrom)	Simptomlar yüngüldür, funksional pozulma müşahidə olunmur.
TDP luteal eksaserbasiyası	Əsas pozuntu (TDP) bütün sikl boyu mövcuddur, luteal fazada güclənir.
Bipolyar pozuntu	Hipomanik/manik epizodlar mövcuddur.
tiroid pozuntusu	TSH.
Endometrioz, dismenore	Çanaq ağrısı üstünlük təşkil edir; əhval simptomları azdır.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- DRSP və ya PRISM əhval gündəliyi.
- PHQ-9, ÜTP-7 — komorbidlik.
- Çanaq müayinəsi (ginekoloq) və TSH — somatik səbəblər istisna.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (ACOG, ISPMD, APA 2010)

1. SSGİ birinci sıra: fluoksetin, sertralin, paroksetin (FDA təsdiqi PMDP üçün), esitalopram. İki rejim mümkündür:
    - Davamlı (gündəlik): bütün siklda.
    - Luteal fazada fasiləli rejim: ovulyasiyadan menstruasiya başlanğıcına qədər (təqribən 14 gün) — davamlı rejimlə müqayisə oluna bilən effektivlik (Cochrane: Marjoribanks J. və b. 2013, CD001396).
2. Hormon supresiyası — kombinə edilmiş oral kontraseptivlər (xüsusilə drospirenon-tərkibli — Yaz, Beyaz; FDA tərəfindən təsdiqlənmiş); GnRH agonistləri (leuprolid) refrakter hallarda.
3. Ooforektomiya yalnız refrakter ağır hallarda sonuncu seçim kimi tətbiq edilir; estrogen əvəzedici terapiya ilə.
4. KDT — adjunkt; Lustyk M.K. və b. icmalları mülayim effekt göstərmişdir.
5. Həyat tərzi: fiziki aktivlik, kafein və alkoqolun azaldılması — əlavə tədbir kimi.

6. Kalsium əlavəsi (1200 mq/gün) — Thys-Jacobs S. və b. Am J Obstet Gynecol 1998 RKİ — mülayim effekt; adjunkt rolda.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Problemlərin Şiddətinin Gündəlik Qeydi (ing. Daily Record of Severity of Problems, DRSP) — Endikot C. (Endicott J.) — 21 simptom, gündəlik 1–6 bal qeydiyyatı; PMDP diaqnozu üçün prospektiv 2 sikl tələb olunur.
2. SSGİ — Luteal Faza Rejimi — Ovulyasiyadan (14-cü gün) menses başladığına qədər; davamlı istifadə qədər effektivdir (Cochrane: Marjoribanks J. və b. 2013).
3. Drospirenon-tərkibli Oral Kontraseptiv — Yaz, Beyaz — FDA təsdiqi PMDP üçün; hormonal stabilizasiya.
4. Qonadotropin-azad edən hormon (GnRH) agonistləri (leuprolid) refrakter hallarda ovarial supressiya üçün tətbiq edilir; uzunmüddətli istifadədə osteoporoz riski.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- ACOG (ing. American College of Obstetricians and Gynecologists) Practice Bulletin: SSGİ-lər birinci sıra, oral kontraseptivlər ikinci sıra dərman vasitələridir.
- ISPMD (ing. International Society for Premenstrual Disorders) konsensus: davamlı və luteal SSGİ rejimləri eyni effektivliyə malikdir; GnRH agonistləri refrakter hallarda tətbiq edilir.

9. Proqnoz

- SSGİ və ya hormonal müalicə ilə əksər pasiyentlərdə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Reproduktiv dövr ərzində davam edir; menopozadan sonra remissiya.
- İzləmə — sikl simptomları, kompliyans, yan təsirlər, komorbidlik.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «PMDP — „qadın iradi zəifliyi“dir, tibbi pozuntu deyil»

Sübut: Schmidt P.J. NEJM 1998 — yumurtalıq hormonlarının supressiyası simptomları aradan qaldırır, hormonların yenidən verilməsi simptomları geri qaytarır; neyrobioloji əsaslı pozuntudur. DSM-5 və XBT-11 rəsmi diaqnoz.

Mif 2: «PMDP həm də PMS-dir, fərq yoxdur»

Sübut: PMS qadınların 30–80%-də yüngül formada; PMDP klinik şiddət və funksional pozulma ilə xarakterizə olunur — qadınların 3–8%-də.

Mif 3: «SSGİ PMDP-də əhəmiyyətli effekt göstərmir, depressiya kimi gözləmək lazımdır»

Sübut: SSGİ PMDP-də sürətli (1–2 gün ərzində) effekt göstərir — major depressiyadan fərqli farmakodinamik mexanizm; serotoninergik sistemə birbaşa təsir göstərir.

Mif 4: «Yalnız hormonal müalicə (hamiləlik, hormon əvəzləyici terapiya) effektivdir»

Sübut: SSGİ və hormonal müalicə hər ikisi effektivdir; SSGİ birinci sıra (əksər pasiyent üçün); hormonal — ginekoloji komorbidlik və ya pasiyent seçimi ilə.

Mif 5: «Bitki preparatları (ing. chasteberry, evening primrose oil, St John's Wort) PMDP-ni sağaldır»

Sübut: chasteberry (Vitex agnus-castus) bəzi tədqiqatlarda PMS üçün orta dərəcəli effekt; PMDP üçün sübut bazası məhduddur. Gecə şamı yağı (ing. evening primrose oil) üzrə Cochrane icmalı mənfi nəticələr göstərmişdir. St John's Wort — SSGİ-yə qarşılıqlı təsir riski.

Mif 6: «Kraniosakral terapiya, homeopatiya, akupunktura PMDP-ni keçirər»

Sübut: bu komplementar müdaxilələrin PMDP üçün effekti sübut edilməmişdir.

Mif 7: «PMDP diaqnozu retrospektiv tarixçədən qoyula bilər»

Sübut: retrospektiv qeydlər etibarsızdır; prospektiv 2 sikl gündəliyi diaqnoz üçün məcburidir — bu, diaqnozun nadir qoyulmasının əsas səbəbidir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). GA34.41 Premenstrual disforik pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Yonkers K.A., O'Brayen P.M., Eriksson E. Premenstrual sindrom. «Lancet». 2008;371(9619):1200–1210.
4. Şmidt P.C., Nieman L.K., Danaseau M.A., Adams L.F., Rubinov D.R. Premenstrual sindromu olan və olmayan qadınlarda gonadal steroidlərin

differensial davranış təsirləri. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 1998;338(4):209–216.

5. Steiner M., Steinberg S., Stüart D. və b. Premenstrual disforiyanın müalicəsində fluoksetin. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 1995;332(23):1529–1534.
6. Tis-Yakobs S., Starkey P., Bernşteyn D., Tian C. Kalsium karbonat və premenstrual sindrom. «Amerika Obstetriya və Ginekologiya Jurnalı» (Am J Obstet Gynecol). 1998;179(2):444–452.
7. Amerika Obstetriya və Ginekologiya Kolleci (ACOG). «ACOG Praktik Bülleteni № 15». Premenstrual sindrom. 2000 (yenidən baxılmış).
8. Nevatte T., O'Brayen P.M.S., Bəkström T. və b. Premenstrual pozuntuların idarə edilməsi üzrə Beynəlxalq Premenstrual Pozuntular Cəmiyyətinin (ISPMD) konsensusu. «Qadın Sağlamlığı üzrə Psixiatriya Arxivləri» (Arch Womens Ment Health). 2013;16(4):279–291.
9. İsmaili E., Volş S., O'Brayen P.M.S. və b. Beynəlxalq Premenstrual Pozuntular Cəmiyyətinin (ISPMD) dördüncü konsensusu: premenstrual pozuntunun diaqnostikası və idarə edilməsi üzrə auditə uyğun standartlar. «Qadın Sağlamlığı üzrə Psixiatriya Arxivləri» (Arch Womens Ment Health). 2016;19(6):953–958.
10. Treloar S.A., Hit A.C., Martin N.G. Premenstrual simptomlara genetik və ətraf mühit amillərinin təsiri. «Psixoloji Tibb» (Psychol Med). 2002;32(1):25–38.
11. Marcoribanks C., Braun C., O'Brayen P.M.S., Vyatt K. Premenstrual sindrom üçün selektiv serotoninin geri alınması inhibitorları. «Cochrane Sistemli İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2013; (6):CD001396.
12. Endikott C., Ni C., Harrison V. Gündəlik Problemlərin Ağırlıq Səviyyəsi Qeydi (DRSP): etibarlılıq və validlik. «Qadın Sağlamlığı üzrə Psixiatriya Arxivləri» (Arch Womens Ment Health). 2006;9(1):41–49.
13. Lustyk M.K.B., Gerriş V.G., Şaver S., Keys S.L. Premenstrual sindrom və premenstrual disforik pozuntu üçün koqnitiv-davranış terapiyası: sistemli icmal. «Qadın Sağlamlığı üzrə Psixiatriya Arxivləri» (Arch Womens Ment Health). 2009;12(2):85–96.

6B00–6B0Z TƏŞVİŞ VƏ QORXU İLƏ ƏLAQƏLİ POZUNTULAR (XBT-11)

Təşviş və ya qorxu ilə əlaqəli pozuntular (ing. Anxiety or fear-related disorders)

XBT-11 **6B00**	**6B00 GENERALİZƏ OLUNMUŞ TƏŞVİŞ POZUNTUSU (ÜTP)** **Generalised anxiety disorder**
XBT-10 F41.1	Ümumiləşmiş təşviş pozuntusu
DSM-5-TR F41.1	Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu (ing. XBT-11: 6B00 Generalised Anxiety Disorder; DSM-5-TR: F41.1) — ən azı bir neçə ay (DSM-5-TR-də ≥ 6 ay) ərzində davam edən, çoxsaylı həyat sahələrini (iş, ailə, sağlamlıq, gündəlik mövzular) əhatə edən, idarə oluna bilməyən, yetərli səbəb olmadan yaranan həddən artıq narahatlıqla xarakterizə olunan pozuntudur. Bu pozuntu əhəmiyyətli somatik simptomlarla (gərginlik, yorğunluq, yuxu pozulması) müşayiət olunur.

2. Tarixçə

- 1920–60-cı illər — «təşviş nevrozu» (ing. «anxiety neurosis») termini, Ziqmund Freydin təsiri ilə bağlıdır.
- DSM-III (1980) — «anxiety neurosis» → panik pozuntu və ÜTP ayrılması; ÜTP residual kateqoriya idi.
- DSM-IV (1994), DSM-5 (2013) — ÜTP ayrı pozuntu kimi; ≥ 6 aylıq müddət; xarakterik somatik simptomlar.
- XBT-11 (2019) — diaqnoz üçün müddət tələbini «bir neçə ay» kimi formulə etmişdir (DSM-5-dən az sərt).

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 3–9% (Kessler R.C. və b. WMH icmalları).
- İllik yayılma: təxminən 2–3%.
- Cins: qadınlarda 2 dəfə çoxdur.
- Başlanğıc ikipilləlidir (ing. bimodal) — yeniyetməlik və orta yaş; gedişi çox vaxt xronikdir.
- Komorbidlik: TDP təxminən 60%, sosial təşviş pozuntusu, panik pozuntu, maddə istifadəsi, somatik (qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, kardial şikayətlər).

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 30–40% (Hettema J.M. və b. Am J Psychiatry 2001 meta-analiz).
- Neyrobioloji — amigdala hiperresponsivliyi, prefrontal-amigdala tənzimləməsinin pozulması; GABA-ergik və serotoninergik disregulasiya.
- Şəxsiyyət xüsusiyyətləri (nevrotizm, davranışın inhibisiyası) yüksək risk amilləridir.
- Mühit — uşaqlıq travması, xronik stress, valideynin hədsiz himayəsi.

5. Klinik təzahürlər

5.1 Psixoloji simptomlar

- Çoxsaylı sahələri əhatə edən idarə oluna bilməyən narahatlıq.
- «Narahatlıq haqqında narahatlıq» (ing. «worry about worry») — meta-narahatlıq (Wells A. konsepsiyası).
- Konsentrasiya çətinliyi, fikrin boş qalması.
- Qıcıqlanma.

5.2 Somatik simptomlar

- Əzələ gərginliyi.
- Yorğunluq.
- Yuxu pozulması (yatmaq çətinliyi, yuxunu saxlaya bilməmək).
- Avtonom simptomlar (taxikardiya, tər, ağız quruluğu, baş ağrısı).
- Qastrointestinal şikayətlər — QBS komorbidliyi sıxdır.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Həddən artıq narahatlıq və ya gərginlik, çoxsaylı sahələrə yönəlmiş; gündəlik fəaliyyətin əksər hissəsində mövcuddur; ≥ 6 ay (DSM-5-TR) / bir neçə ay (XBT-11).

B. Narahatlığı idarə etmək çətinliyi.

C. Aşağıdakılardan ≥ 3 simptom (uşaqlarda 1):

1. Daxili narahatlıq, gərginlik, «əsəbləri üstə» olma hissi;
2. Asanlıqla yorulma;
3. Konsentrasiya çətinliyi;
4. Qıcıqlanma;
5. Əzələ gərginliyi;
6. Yuxu pozulması.

D. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

E. Maddə qəbulu və ya tibbi vəziyyətlə bağlı olmamalıdır (istisna edilməsi).

F. Başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: ≥ 6 aylıq müddət; ≥ 3 simptom (somatik və koqnitiv)
- XBT-11: müddət «bir neçə ay» — daha az sərt; somatik simptomlar tələb edilir, lakin spesifik say göstərilmir.
- NICE CG113 (Böyüklərdə ümumiləşmiş təşviş pozuntusu və panik pozuntu: idarəetmə; ing. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management; 2011, 2020-ci il yenilənməsi): mərhələli (pilləli) yanaşma — psixoedukasiya və müşahidə → rəhbərlik altında özünəyardım → koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) və ya farmakoterapiya → kombinasiya → ağır halda ixtisaslaşmış xidmət.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (narahatlıq sahələri, tətikləyicilər, somatik simptomlar, qaçınma).
2. SCID-5, MINI.
3. ÜTP-7 (skrininq, ilkin göstəricilər və izləmə) — ≥ 10 bal — orta dərəcəli, ≥ 15 bal — ağır narahatlıq.
4. Hamilton təşviş şkalası (HAM-A) — klinikçi-rated.

5. Komorbidlik skrininq (PHQ-9 depressiya, panik, sosial narahatlıq).
6. Somatik səbəbin istisna edilməsi — TSH, anemiya, kardial, kafein və ya stimulyant istifadəsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici əlamətlər
Panik pozuntu (6B01)	Ayrı-ayrı panik atakalar.
Sosial qorxu (6B04)	Sosial qiymətləndirmə qorxusu dominant.
OKP (6B20)	Eqo-distonik obsessiyalar, kompulsiyalar.
PTSP (6B40)	Travma tarixçəsi, intruziv simptomlar.
TDP (major depressiv pozuntu; XBT-11: 6A70/6A71)	Affektiv simptomlar dominant.
Hipertiroid	TSH azalma, fiziki əlamətlər.
Kafein və ya stimulyant intoksikasiyası	İstifadə tarixçəsi.
Aritmiya, feoxromositoma	Spesifik kardial və endokrin testlər.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- ÜTP-7, HAM-A, PSWQ (ing. Penn State Worry Questionnaire).
- Laboratoriya və instrumental müayinələr (TSH, tam qan analizi, kafein və alkohol istifadəsinin qiymətləndirilməsi).
- EKG (kardial şikayət varsa).

8. Müalicə

8.1 Pilləli yanaşma (NICE CG113, CANMAT 2014)

1. Pillə 1 — psixoedukasiya və aktiv müşahidə.
2. Pillə 2 — rəhbərlik altında özünəyardım (internet əsaslı KDT), psixoedukasiya qrupları.
3. Pillə 3 — yüksək intensivlikli KDT və ya farmakoterapiya.
4. Pillə 4 — ixtisaslaşmış xidmət: kombinasiya müalicəsi, refrakter hallar.

8.2 Birinci sıra

Psixoterapiya — koqnitiv-davranış terapiyası (KDT). Ən güclü sübut bazasına malik metoddur; 12–20 seansdan ibarətdir. Tərkib hissələri:

- Koqnitiv yenidən strukturlaşdırma — təşviş haqqında inancların yoxlanması: «narahat olmaq məni hazırlıqlı saxlayır» tipli qənaətlərin faktla üzləşdirilməsi.
- Qeyri-müəyyənliyə dözümsüzlüklə iş (Dugas M.J. modeli) — pasiyent nəticəsi bilinməyən vəziyyətlərlə qəsdən üzləşir və dözümlülüyünü artırır.
- Ekspozisiya (məruz qalma) — təşviş doğuran vəziyyətlərdən qaçınmanın pilləli şəkildə dayandırılması; təxirə salınmış qərarların icrası.
- Problem-həll təlimi — real problemi həll edilə bilən addımlara bölmək, həll edilməyəni qəbul etmək.
- Relaksasiya — proqressiv əzələ boşalması, diafraqmal tənəffüs.

Effekt: Cuijpers P. və müəlliflərin icmallarında orta-böyük effekt ölçüsü; nəticə farmakoterapiya ilə müqayisə edilə biləndir, residiv riski isə daha aşağıdır.

Farmakoterapiya. Effekt 4–6 həftədə qiymətləndirilir, tam cavab üçün 8–12 həftə lazım ola bilər:

- SSGİ — sertralin, essitalopram, paroksetin.
- SNGİ — venlafaksin, duloksetin.
- Aşağı doza ilə başlanılır: ilk günlərdə təşvişin müvəqqəti güclənməsi mümkündür.

Slee A. və müəlliflər (Lancet 2019) şəbəkə meta-analizində duloksetin, preqabalin və venlafaksin yüksək effektivliyə malik olmuşdur; dözümlülük profili isə dərman vasitəsindən asılı olaraq dəyişir.

8.3 İkinci sıra

- Preqabalin — Avropada bu diaqnoz üçün təsdiqlənmişdir; effekti sürətli, lakin asılılıq potensialı var.
- Buspiron qismən effektivdir və benzodiazepinlərə alternativ kimi istifadə olunur.
- Mirtazapin — əlavə preparat kimi, yuxu pozulması müşayiət edərsə.
- Kvetiapin — CANMAT 2014-də ikinci sıra; metabolik yan təsirlərə görə məhdud istifadə.

8.4 Qısamüddətli istifadə və məhdudiyyətlər

- Benzodiazepinlər — yalnız kəskin dövrdə, 2–4 həftədən artıq olmayaraq. Asılılıq potensialı yüksəkdir, davamlı istifadə tövsiyə edilmir.

8.5 Əlavə metodlar

- Diqqətlilik əsaslı stressin azaldılması (MBSR) və diqqətlilik əsaslı koqnitiv terapiya (MBCT) — 8 həftəlik qrup proqramı; bu pozuntuda mülayim effekt. Hofmann S.G. və müəlliflər, J Consult Clin Psychol 2010 meta-analiz.
- Qəbul və öhdəlik terapiyası (QÖT) — simptomla mübarizə əvəzinə onunla birlikdə dəyərlərə uyğun həyatağı öyrədir; psixoloji çevikliyi artırır. Roemer L. və müəlliflərin randomizə olunmuş tədqiqatları.
- Tətbiqi relaksasiya (Öst L.G. metodu) — strukturlaşdırılmış proqressiv əzələ boşalması, təşviş tətikləyicisi qarşısında tətbiq edilir.
- Həyat tərzi — kofeinin məhdudlaşdırılması, müntəzəm fiziki aktivlik, yuxu gigiyenası, alkohol və psixoaktiv maddələrdən imtina.

8.6 Müalicənin müddəti

- Remissiyadan sonra ən azı 12 ay davam etdirilir.
- Xronik gediş və ya çoxsaylı residiv halında müalicə uzunmüddətli planlaşdırılır.
- Dayandırma pilləli aparılır: qəfil kəsmə residiv riskini artırır.

8.7 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG113 (2011, 2020-ci ildə təsdiqlənmişdir) — pilləli yanaşma; birinci sıra farmakoterapiya SSGİ və SNGİ; benzodiazepin yalnız kəskin, qısa müddətə.
- APA — bu pozuntu üzrə ayrıca göstərişi yoxdur; bu sənədlər qrupunda yeganə sənəd panik pozuntuya aiddir (2009, arxiv statusunda). Buna görə istinad NICE CG113 və CANMAT 2014-ə edilir.
- CANMAT 2014 (Katzman M.A. və müəlliflər) — birinci sıra esitalopram, sertralin, venlafaksin, duloksetin; ikinci sıra preqabalin, buspiron, mirtazapin, kvetiapin.

9. Proqnoz

- Xronik gediş; spontan remissiya az.
- Adekvat müalicə ilə əhəmiyyətli simptom azalması və funksional yaxşılaşma.

- Komorbid TDP pis proqnoz markeri.
- İzləmə — ÜTP-7 ilə monitorinq, yan təsirlər, kompliyans, komorbidlik.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Narahatlıq adi həyat hissidir, tibbi vəziyyət deyil»

Sübut: normal narahatlıq və ÜTP arasında klinik fərq mövcuddur — şiddət, müddət (≥ 6 ay), idarə oluna bilməmə, somatik komponentlər, funksional pozulma. Klinik diaqnoz dəqiq meyarlar əsasında qoyulur.

Mif 2: «Benzodiazepinlər ÜTP-ın birinci sıra müalicəsidir»

Sübut: NICE CG113, APA, CANMAT — benzodiazepinlər yalnız qısamüddətli (2–4 həftə) istifadə üçün; asılılıq potensialı yüksəkdir; SSGİ və SNGİ birinci sıra.

Mif 3: «Yalnız relaksasiya və ya yoga ÜTP-ı sağaldır»

Sübut: mülayim adjunkt effekt göstərirlər, lakin orta-ağır halda KDT və ya farmakoterapiya tələb olunur.

Mif 4: «Antidepresanlar narahatlıq üçün effektsizdir — onlar depressiya üçündür»

Sübut: SSGİ və SNGİ təşviş pozuntularında effektivdir; serotoninergik sistemin amigdala fəaliyyətinə təsiri ilə. CANMAT 2014, Slee Lancet 2019.

Mif 5: «Pasiyent iradi olaraq narahat olmamağı öyrənə bilər»

Sübut: ÜTP neyrobioloji disregulasiyadır; KDT və ya farmakoterapiya neyrobioloji səviyyədə təsir edir.

Mif 6: «Kafein məhdudlaşdırması ÜTP üçün kifayətdir»

Sübut: kafein simptomları gücləndirə bilər; məhdudlaşdırma köməkçi addımdır, əsas müalicə deyil.

Mif 7: «Bitki mənşəli dərman vasitələri (kava, valeriana, passiflora) standart müalicəni əvəz edə bilər»

Sübut: kava ciddi hepatotoksiklik (bir neçə ölüm halı — FDA xəbərdarlığı); valerian və passiflora effekti zəif; dazıotu (ing. Hypericum perforatum) ilə qarşılıqlı təsir.

Mif 8: «Kanabis (kannabidiol — KBD) narahatlığı sağaldır»

Sübut: CBD üçün ilkin tədqiqatlar var, lakin klinik tövsiyə üçün kafi deyil; THK (tetrahidrokannabinol) narahatlığı gücləndirə və ya panik atak yarada bilər.

Mif 9: «Antidepresanları ömürlük istifadə etməli olacaqsınız»

Sübut: remissiyadan sonra 12 ay; sonra tədricən kəsmə mümkündür; residiv halda yenidən başlanılır.

Mif 10: «Refrakter ÜTP-da elektrokonvulsiv terapiya effektivdir»

Sübut: EKT ÜTP üçün göstəriş deyil; refrakter halda — dərman vasitəsinin dəyişdirilməsi, kombinasiya, atipik antipsixotik köməkçi müalicə.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B00 Yayılmış təşviş pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) CG113. Böyüklərdə yayılmış təşviş pozuntusu və panik pozuntusu: idarə edilməsi. 2011, 2020 yenilənməsi.
4. Katsman M.A. və b. Təşviş, posttravmatik stress və obsesiv-kompulsiv pozuntuların idarə edilməsi üzrə Kanada klinik təcrübə rəhbərliyi. «BMC Psixiatriyası» (BMC Psychiatry). 2014;14(Əlavə 1):S1.
5. Sli A., Nazaret İ., Bondaronek P. və b. Yayılmış təşviş pozuntusunun farmakoloji müalicəsi: sistemli icmal və şəbəkə meta-analizi. «Lancet». 2019;393(10173):768–777.
6. Hettema C.M., Neale M.C., Kendler K.S. Təşviş pozuntularının genetik epidemiologiyasının icmalı və meta-analizi. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2001;158(10):1568–1578.
7. Hofmann S.Q., Soyer A.T., Vitt A.A., Oh D. Diqqətlilik əsaslı terapiyanın təşviş və depressiyaya təsiri. «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 2010;78(2):169–183.
8. Spitzer R.L., Kroenke K., Williams C.B., Löwe B. Ümumiləşmiş təşviş pozuntusunun qiymətləndirilməsi üçün qısa ölçü: ÜTP-7 (ing. GAD-7). «Daxili Xəstəliklər Arxivləri» (Arch Intern Med). 2006;166(10):1092–1097.
9. Kuypers P., Seybrandic M., Kool S. və b. Ümumiləşmiş təşviş pozuntusunun psixoloji müalicəsi: meta-analiz. «Klinik Psixologiya İcmalı» (Clin Psychol Rev). 2014;34(2):130–140.

10. Düqa M.C., Robişo M. Ümumiləşmiş təşviş pozuntusunun koqnitiv-davranışçı müalicəsi. Nyu York: Routledge; 2007.
11. Meyer T.C., Miller M.L., Metzger R.L., Borkovec T.D. Penn State Narahatlıq Sorğu Vərəqinin hazırlanması və etibarlılıq yoxlanışı (validasiya). «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1990;28(6):487–495.
12. Roemer L., Orsillo S.M. Ümumiləşmiş təşviş pozuntusu üçün qəbul əsaslı davranış terapiyasının açıq sınağı. «Davranış Terapiyası» (Behav Ther). 2007;38(1):72–85.
13. Vells A. Təşviş və depressiya üçün metakoqnitiv terapiya. Nyu York: Guilford Press; 2009.
14. Kesler R.C., Berglund P., Demler O. və b. Milli Komorbidlik Tədqiqatının Təkrarında DSM-IV pozuntularının ömürlük yayılması və başlanğıc yaşının paylanması. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(6):593–602.

XBT-11 **6B01**	**6B01 PANİK POZUNTU** **Panic disorder**
XBT-10 F41.0	Panik pozuntu (epizodik paroksizmal təşviş)
DSM-5-TR F41.0	Panik pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Panik pozuntu (XBT-11: 6B01; DSM-5-TR: F41.0) — təkrarlanan, gözlənilməz panik atakaları (zirvəsinə 10 dəqiqə ərzində çatan kəskin qorxu və ya narahatlıq epizodları) və bu atakaların təkrarı haqqında davamlı narahatlıq, davranış dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunan pozuntudur.

2. Tarixçə

- Da Costa J.M. (1871) «irritable heart» — Amerika Vətəndaş müharibəsi əsgərlərində müşahidə edilmişdir.
- Ziqmund Freyd (1894) «anxiety neurosis».
- Klein D.F. (1964) — panik atakaların antidepresanlara cavabı əsasında ayırd edilməsi; «anxiety neurosis» parçalanmasının əsası.
- DSM-III (1980) — Panik pozuntu rəsmi diaqnoz.

- DSM-5 (2013), XBT-11 — aqorafobiya panik pozuntudan ayrı kateqoriya kimi müəyyən edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 2–5%; illik təxminən 2,7% (Kessler R.C. WMH).
- Cins: qadınlarda 2 dəfə yüksək.
- Başlanğıc: gənc-orta yetkinlik (20–30 yaş); ikinci zirvə orta yaşdadır.
- Komorbidlik: aqorafobiya 30–50%, TDP 50–60%, başqa təşviş pozuntuları, maddə istifadəsi, mitral qapaq prolapsı.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik təxminən 40% (Hettema 2001 meta-analiz).
- Neyrobioloji — amigdala–mavi ləkə–prefrontal qabıq dövrəsi hiperreaktivliyi; serotoninergik, noradrenergik, GABA-ergik disregulasiya.
- CO_2 həssaslıq hipotezi (Klein D.F. «boğulma yalançı siqnalı») — pasiyentlər hiperventilyasiya və CO_2 yığılmasına həssaslıq göstərir.
- Şəxsiyyət — narahatlığa həssaslıq (narahatlığa həssaslıq — ing. anxiety sensitivity; Reiss S. konsepsiyası); uşaqlıqda ayrılma narahatlığı tarixçəsi.

5. Klinik təzahürlər

Panik atak: 4 və daha çox simptom, zirvə 10 dəqiqə ərzində

- Ürək döyüntüsü, çırpıntı, taxikardiya.
- Tər basması, titrəmə.
- Təngnəfəslik, hava çatışmazlığı hissi.
- Boğulma hissi.
- Sinə ağrısı və ya rahatsızlıq.
- Ürəkbulanma, qarında narahatlıq.
- Başgicəllənmə, qeyri-real hissi.
- Soyuq və ya isti dalğalar; paresteziya.
- Derealizasiya, depersonalizasiya.
- Nəzarət itkisi və ya «ağlını itirmək» (ing. going crazy) qorxusu.
- Ölüm qorxusu.

Atak 5–20 dəqiqə davam edir; xəstəxana qəbulu sıxdır (kardial şikayət ilə).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Təkrarlanan gözlənilməyən panik atakları.

B. Ən azı bir atakdan sonra ≥ 1 ay aşağıdakılardan biri:

- Növbəti atakdan davamlı narahatlıq;
- Atakların nəticələri haqqında qorxu (ürək tutması, ağlını itirmək);
- Atakla əlaqəli əhəmiyyətli davranış dəyişikliyi (qaçınma, təhlükəsizlik davranışları).

C. Maddə və ya tibbi vəziyyət istisnası.

D. Başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur (sosial təşviş pozuntusu, OKP, PTSP, ayrılma narahatlığı pozuntusu).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — aqorafobiya ayrı diaqnoz (F40.00); birgə baş verə bilər.
- XBT-11 — aqorafobiya 6B02 ayrı kod; lakin bir aylıq narahatlıq müddəti tələb olunmur — «davamlı narahatlıq» kifayətdir.
- NICE CG113 — diaqnoz somatik səbəbin istisna edilməsindən sonra qoyulur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və atak tarixçəsi.
2. SCID-5, MINI.
3. PDSS (ing. Panic Disorder Severity Scale), ÜTP-7 komorbidlik.
4. Tibbi: EKG, TSH, tam qan, qlükoza, kafein/stimulyant; feoxromositoma şübhəsi — sidikdə metanefrinin 24 saatlıq təyini.
5. Komorbidlik (aqorafobiya, TDP, maddə istifadəsi).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Aqorafobiya (6B02)	Qaçınma sahələri əsas; komorbid mümkün.
Sosial qorxu (6B04)	Sosial qiymətləndirmə tətikləyicisi.
Spesifik fobiya (6B03)	Müəyyən obyekt və ya vəziyyət.

Vəziyyət	Fərqləndirici
PTSP (6B40)	Travma tarixçəsi, intruzivlər.
Hipertiroid	TSH.
Feoxromositoma	Sidik metanefrin.
Aritmiya (SVT)	Holter EKG.
Maddə ilə yaranan (kafein, kokain)	Toksikoloji.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PDSS, Aqorafobik Koqnisiyalar Şkalası (ACQ) və Bədən Hissləri Sorğu Vərəqi (BSQ).
- EKG, TSH, tam qan, qlükoza.
- Holter EKG (aritmiya şübhəsi).
- Toksikoloji.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG113, CANMAT 2014)

1. KDT panik üçün — psixoedukasiya, interoseptiv ekspozisiya (bədən siqnallarına dözümün artırılması), real şəraitdə ekspozisiya (qaçınılan vəziyyətlərə), koqnitiv yenidən strukturlaşdırma. 12–16 seans. Sübut: Cuijpers P. və b. icmalları — böyük effekt.
2. Farmakoterapiya: SSGİ (sertralin, paroksetin, fluoksetin — FDA-nın panik pozuntu göstərişi; esitalopram off-label) və ya SNGİ (venlafaksin) — birinci sıra. Başlanğıc aşağı dozada — «aktivasiya» effekti (əsəbilik, daxili narahatlıq) paniki gücləndirə bilər.
3. Benzodiazepin (klonazepam, lorazepam) — qısamüddətli ilkin stabilizasiya; ≤ 4 həftə; asılılıq potensialı.
4. Müalicə müddəti — remissiyadan sonra ≥ 12 ay.
5. Kafeinin, alkoholun və kanabisin qəbulu məhdudlaşdırılmalıdır.

8.2 Müalicə metodları

1. Panik üçün KDT — Klark (Clark D.M.), Barlou (Barlow D.) — İnteroseptiv ekspozisiya (qəsdən bədən hissi yaratma — hiperventilyasiya, fırlanma, kafein), real şəraitdə ekspozisiya və koqnitiv yenidən strukturlaşdırma. Sübut: Barlow D.H. və b. JAMA 2000 RKİ.

2. Panikaya Nəzarət Terapiyası (PNT) — Barlou (Barlow D.) — 11 seanslı standartlaşdırılmış protokol; ABŞ-da geniş istifadə.
3. Panik Pozuntu Şiddət Şkalası (ing. Panic Disorder Severity Scale, PDSS) — Şir (Shear M.K.) — 7 maddə; ilkin göstəricilər və izləmə.
4. İnternet əsaslı KDT (iKDT — internet əsaslı KDT) — Andersson G. və b. RKİ-ləri — fərdi KDT ilə müqayisə edilə bilən effekt göstərmişdir.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG113 — KDT və SSGİ birinci sıra; benzodiazepin yalnız qısamüddətli.
- APA Anxiety Guidelines — KDT və farmakoterapiya bərabər effektiv.
- Mitte K. J Affect Disord 2005 meta-analiz — KDT plasebodan və gözləmə siyahısı qrupundan üstün.

9. Proqnoz

- Müalicə ilə remissiya əksər pasiyentlərdə.
- Komorbid aqorafobiya və ya TDP pis proqnoz.
- Erkən müdaxilə qaçınma davranışının möhkəmlənməsinin qarşısını alır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Panik atak — ürək tutmasıdır»

Sübut: simptomlar oxşar ola bilər; lakin panik atak qısamüddətli olur və xəstəxanaya müraciət zamanı EKG normal olur. Kleinin «boğulma yalançı siqnalı» hipotezi mexanizmi izah edir.

Mif 2: «Pasiyent iradi olaraq paniki idarə edə bilər»

Sübut: panik neyrobioloji disregulasiyadır; KDT və farmakoterapiya tələb olunur.

Mif 3: «Benzodiazepin panikin əsas müalicəsidir»

Sübut: qısamüddətli stabilizasiya üçün; asılılıq potensialı; SSGİ və KDT birinci sıra.

Mif 4: «Panik pasiyenti panik yaradan situasiyalardan qorumaq lazımdır»

Sübut: qaçınma simptomları gücləndirir; ekspozisiya əsas terapevtik mexanizmdir.

Mif 5: «Bitki preparatları (kava, valerian) panik üçün təhlükəsizdir»

Sübut: kava hepatotoksiklik (FDA xəbərdarlığı); standart müalicə üstün.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6B01 Panika pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). CG113. 2011/2020.
4. Katzman M.A. və b. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) 2014. «BMC Psixiatriyası» (BMC Psychiatry). 2014;14(Əlavə 1):S1.
5. Barlou D.H. və b. Panika pozuntusu üçün koqnitiv-davranışçı terapiya, imipramin və ya onların kombinasiyası. «JAMA». 2000;283(19):2529–2536.
6. Şir M.K. və b. Çoxmərkəzli kolaborativ panika pozuntusu ağırlıq şkalası. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 1997;154(11):1571–1575.
7. Kleyn D.F. Yalançı boğulma həyəcanları, spontan panikalar və əlaqəli vəziyyətlər. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 1993;50(4):306–317.
8. Klark D.M. Panikaya koqnitiv yanaşma. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1986;24(4):461–470.
9. Andersson Q., Kuypers P., Karlbrinq P. və b. Psixiatrik və somatik pozuntular üçün rəhbərlik edilən internet əsaslı və üzbəüz koqnitiv davranış terapiyası: sistematik icmal və meta-analiz. «Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry). 2014;13(3):288–295.
10. Reiss S., Peterson R.A., Qurski D.M., MakNalli R.C. Təşviş həssaslığı, təşviş tezliyi və qorxaqılığın proqnozlaşdırılması. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1986;24(1):1–8.
11. Kesler R.C., Berglund P., Demler O. və b. Milli Komorbidlik Tədqiqatının Təkrarında DSM-IV pozuntularının ömürlük yayılması və başlanğıc yaşının paylanması. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(6):593–602.

XBT-11 **6B02**	**6B02 AQORAFOBİYA** **Agoraphobia**
XBT-10 F40.0	Aqorafobiya
DSM-5-TR F40.00	Aqorafobiya

1. Tərif və nozologiya

Aqorafobiya (XBT-11: 6B02; DSM-5-TR: F40.00) — qaçışın çətin olduğu və ya kömək əldə oluna bilməyəcəyi vəziyyətlərdən (ictimai nəqliyyat, açıq sahələr, qapalı sahələr, izdiham, evdən tək çıxma) həddən artıq qorxu və qaçınmadır. Pasiyent panik atak və ya digər fəaliyyəti pozan simptomların inkişaf etməsindən qorxur.

2. Tarixçə

- Westphal C. (1872) «aqorafobiya» (ing. «agoraphobia») — yunan «agora» (meydan) və «fobos» (qorxu) sözlərindən yaranmışdır.
- DSM-III (1980)-də panik pozuntu ilə birlikdə təsnif edilmişdir.
- DSM-5 (2013), XBT-11 — aqorafobiya panik pozuntudan ayrıca kateqoriya kimi rəsmiləşdirilmişdir (komorbidlik mümkündür, lakin hər biri ayrı diaqnoz kimi qoyulur).

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 1–2,5%.
- Cins: qadınlarda 2 dəfə çoxdur.
- Başlanğıc: gənc-orta yetkinlik.
- Komorbidlik: panik pozuntu 50%, TDP, başqa narahatlıq, maddə istifadəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik təxminən 48% (Mosing M.A. və b. Depress Anxiety 2009;26(11):1004–1011).
- Klassik şərtləndirmə — panik atak müəyyən vəziyyətdə baş verdikdə həmin vəziyyətə qorxu keçir.
- Koqnitiv amillər — katastrofizasiya (fəlakətləşdirmə) («kömək gəlməyəcək»).

5. Klinik təzahürlər

Tipik qaçınılan vəziyyətlər:

- İctimai nəqliyyat (avtobus, qatar, təyyarə).
- Açıq sahələr (meydan, körpü, geniş ərazi).
- Qapalı sahələr (mağaza, kinoteatr).
- Növbə durmaq və ya izdiham.
- Evdən tək çıxma.

Pasiyentdə qaçınma, «təhlükəsizlik» davranışları (yoldaş, mobil telefon, dərman daşıması), qismən və ya tam evə qapanma müşahidə olunur; ağır halda pasiyent ümumiyyətlə evdən çıxa bilmir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Aşağıdakı beş kateqoriyadan 2 və ya daha çoxunda əhəmiyyətli qorxu və ya narahatlıq:

1. İctimai nəqliyyat;
2. Açıq sahələr;
3. Qapalı sahələr;
4. Növbə və ya izdiham;
5. Evdən tək çıxma.

B. Bu situasiyalar qorxulur, çünki panik atak və ya fəaliyyəti pozan simptom baş verdikdə qaçmaq çətin olacaq və ya kömək gəlməyə bilər.

C. Situasiyalar demək olar həmişə qorxu yaradır.

D. Aktiv qaçınma, yoldaş tələbi və ya kəskin narahatlıqla tab gətirmə müşahidə olunur.

E. Qorxu situasiyaya uyğun olmayan dərəcədədir.

F. Simptomlar DSM-5-TR-ə görə ən azı 6 ay davam edir.

G. Əhəmiyyətli funksional pozulma.

H. Tibbi və ya başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — aqorafobiya panik pozuntudan ayrı; komorbid olduqda hər ikisi üzrə diaqnoz qoyulur.
- NICE CG113 — aqorafobiya panik pozuntu ilə oxşar müdaxilə.

6.3 Diaqnostik alqoritm

1. Klinik müsahibə — qaçınılan situasiyalar, panik pozuntu (6B01) tarixçəsi, funksional pozulma.
2. SCID-5, MINI.
3. Aqorafobiya üzrə Mobillik Sorğusu (ing. Mobility Inventory for Agoraphobia, MIA) — qaçınma şiddəti.

4. Komorbidlik (panik, TDP, maddə).
5. Tibbi müayinə.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Panik pozuntu (6B01)	Atak əsas; qaçınma sahələri məhdud və ya yox.
Spesifik fobiya (6B03)	Konkret tək obyekt/situasiya.
Sosial qorxu (6B04)	Sosial qiymətləndirmə qorxusu.
PTSP (6B40)	Travma tarixçəsi.
Ayrılma narahatlığı (6B05)	Yaxın şəxsdən ayrılma qorxusu dominant.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- MIA, ACQ, BSQ.
- ÜTP-7, PHQ-9, PDSS komorbidlik.

8. Müalicə

1. Koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) ekspozisiya əsaslıdır: qaçınılan situasiyalara pilləli canlı (in vivo) ekspozisiya və koqnitiv yenidən strukturlaşdırma tətbiq edilir; birinci sıra müalicədir və effekt böyükdür.
2. SSGİ və ya SNGİ — birinci sıra farmakoterapiya (panik pozuntu kimi).
3. Benzodiazepinlər yalnız qısamüddətli istifadə üçün tövsiyə olunur.
4. Virtual reality ekspozisiya — alternativ vasitə; sübut bazası inkişaf etməkdə.
5. Müalicə müddəti — remissiyadan sonra ≥ 12 ay.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Canlı (in vivo) ekspozisiya — pilləli yaxınlaşma: pasiyent qaçınılan situasiyalara strukturlaşdırılmış şəkildə daxil olur; terapevt müşayiət edə bilər (terapevtin müşayiəti ilə ekspozisiya). Birinci sıra metod.
2. Virtual Reallıq Ekspozisiya Terapiyası (ing. Virtual Reality Exposure Therapy, VRET) — Klinik kontekstdə virtual mühit yaradılır; in vivo ekspozisiyaya alternativ. Botella C. və b. Behav Res Ther 2007.
3. Panik pozuntu üçün KDT (Clark D.M., Barlow D.H.) — aqorafobiyaya uyğunlaşdırılmış — İnteroseptiv + in vivo ekspozisiya.

4. Mobillik Sorğusu (ing. Mobility Inventory for Agoraphobia, MIA) — Çembless D.L. — 27 situasiya; tək və yoldaşla qaçınma dərəcəsi.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG113 — KDT və SSGİ birinci sıra müalicə kimi göstərilir.
- CANMAT 2014 — eyni.
- Sánchez-Meca J. və b. Sánchez-Meca J. və b. Clin Psychol Rev 2010;30(1):37–50 meta-analizinə görə ekspozisiya əsaslı KDT böyük effekt göstərmişdir.

9. Proqnoz

- Ekspozisiya əsaslı KDT ilə əksər pasiyentlərdə funksional bərpa müşahidə olunur.
- Erkən müdaxilə olmadıqda xronikləşmə baş verir və pasiyent evdən çıxa bilmir.
- Komorbid TDP pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Aqorafobiyalı pasiyenti qorxduğu situasiyalarla üzləşdirməmək lazımdır»

Sübut: qaçınma simptomları gücləndirir; ekspozisiya əsas terapevtik mexanizmdir.

Mif 2: «Aqorafobiya panik pozuntunun „alt-tipi“dir»

Sübut: DSM-5-TR və XBT-11 — ayrı diaqnostik kateqoriyalar; komorbid mümkündür, lakin biri olmadan da baş verə bilər.

Mif 3: «Pasiyent „tənbəl“dir, çıxmaq istəmir»

Sübut: aqorafobiya neyrobioloji və davranış əsaslı klinik pozuntudur; bu, iradə zəifliyi və ya xarakter problemi deyildir.

Mif 4: «Yalnız dərman aqorafobiyanı sağaldır, terapiya zəruri deyil»

Sübut: ekspozisiya əsaslı KDT olmadan davamlı remissiya çətindir; farmakoterapiya yalnız özü tətbiq edildikdə qaçınma davranışını dəyişdirmir.

Mif 5: «İnternetdən sifariş və distant təhsil sayəsində evdən çıxmamaq aqorafobiyalı pasiyent üçün uyğun həyat tərzidir»

Sübut: ailənin uyğunlaşdırıcı davranışı (accommodation) qısamüddətli rahatlıq verir, lakin xəstəliyi gücləndirir və funksional səviyyəni azaldır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6B02 Aqorafobiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). CG113. 2011/2020.
4. Sançez-Meka C. və b. Aqorafobiyalı və ya aqorafobiyasız panika pozuntusunun psixoloji müalicəsi: meta-analiz. «Klinik Psixologiya İcmalı» (Clin Psychol Rev). 2010;30(1):37–50.
5. Çamblez D.L., Kaputo Q.C., Casin S.E. və b. Aqorafobiya üçün Hərəkətlilik İnventarı. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1985;23(1):35–44.
6. Botelya K., Qarsia-Palasyos A., Villa H. və b. Panika pozuntusu və aqorafobiyanın müalicəsində virtual reallıq ekspozisiyası. «Klinik Psixologiya və Psixoterapiya» (Clin Psychol Psychother). 2007;14(3):164–175.

XBT-11 **6B03**	**6B03 SPESİFİK FOBİYA** **Specific phobia**
XBT-10 F40.2	Spesifik (izolə olunmuş) fobiyalar
DSM-5-TR F40.2xx	Spesifik fobiya

Spesifik fobiya / 1. Tərif və nozologiya

Spesifik fobiya (XBT-11: 6B03; DSM-5-TR: F40.2xx) — müəyyən obyekt və ya situasiyaya (heyvanlar, qan-inyeksiya-yaralanma, təbii mühit, situasiya) qarşı kəskin, qeyri-rasional qorxu və qaçınmadır. Pasiyent qorxunun həddən artıq olduğunu adətən qəbul edir.

2. Tarixçə

- Hippokrat (e.ə. V–IV əsrlər) — fobiya təsvirləri.
- Westphal C. (1872) — sistematik təsnif.
- Marks I.M. (1969) — sistematik desensitizasiya və ekspozisiya tədqiqatları.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 — alt-tiplər: heyvan, təbii mühit, qan-inyeksiya-yaralanma, situasiya, digər.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma 7–12% — ən sıx təşviş pozuntularındandır.
- Cins üzrə: qadınlarda 2–3 dəfə yüksəkdir (qan-inyeksiya-yaralanma alt-tipi istisnadır — fərq azdır).
- Başlanğıc: uşaqlıq dövrü (heyvan, qan-inyeksiya-yaralanma), gənc yetkinlik (situasiya alt-tipi).

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik təxminən 30% (Hettema 2001).
- Klassik şərtləndirmə (Watson J.B., «Kiçik Albert» təcrübəsi, 1920 — ing. Little Albert), dolayı yolla öyrənmə (ing. vicarious learning), məlumat ötürmə.
- Bioloji hazırlıq (ing. preparedness; Seligman M.E.) — filogenetik cəhətdən əhəmiyyətli stimullara (məs. ilan, hörümçək) qarşı qorxuya genetik yatkınlıq.
- Qan-inyeksiya alt-tipində — vazovagal reaksiya (bradikardiya, hipotenziya, huşun itirilməsi) digər fobiyalardan fərqlənir.

5. Klinik təzahürlər

Alt-tiplər

- Heyvan — hörümçək, ilan, it, böcəklər.
- Təbii mühit — yüksəklik, su, fırtına.
- Qan-inyeksiya-yaralanma alt-tipində vazovagal reaksiya (huşun itirilməsi) xarakterikdir.
- Situasiya alt-tipi — uçuş, lift, tunel, avtomobil idarə etmə, qapalı yer.
- Digər alt-tip — boğulma, qusma, oyuncaq fiqurları, müəyyən səslər.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Konkret obyekt və ya situasiyaya kəskin qorxu və ya narahatlıq.

B. Obyekt/situasiya demək olar həmişə qorxu yaradır.

C. Aktiv qaçınma və ya kəskin narahatlıqla dözmə.

D. Qorxu real riskə uyğun olmayan dərəcədə.

E. Simptomlar DSM-5-TR-ə görə ən azı 6 ay davam edir.

F. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

G. Başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR və XBT-11-ə görə alt-tip kvalifikatoru məcburidir.
- NICE — ayrıca spesifik fobiya göstərişi yox; ümumi narahatlıq prinsipləri.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Qorxu Sorğusu Şkalası (FSS — Fear Survey Schedule) və spesifik fobiya alt-şkalaları tətbiq edilir.
3. Funksional pozulmanın qiymətləndirilməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Panik pozuntu (6B01)	Atak gözlənilməyəndir.
Aqorafobiya (6B02)	Çoxsaylı situasiya kateqoriyası.
Sosial təşviş (6B04)	Sosial qiymətləndirmə qorxusu.
OKP (6B20)	Obsessiya əsas; çirklənmə qorxusu kompulsiyalarla.
PTSP (6B40)	Travma tarixçəsi.
Hipoxondriya (6B23)	Xəstəlik qorxusu.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- FSS, spesifik fobiya şkalası.
- Davranış Qaçınma Testi (ing. BAT — Behavioral Avoidance Test) — pasiyentin fobik obyektə yaxınlaşma dərəcəsini ölçür.

8. Müalicə

1. Ekspozisiya terapiyası birinci sıra və ən effektivdir. Tək seans 2–3 saatlıq strukturlaşdırılmış ekspozisiya (ing. Öst L.G. təkseanslı müalicə — one-session treatment) əksər heyvan və situasion fobiyalar üçün effektivdir.
2. Pilləli in vivo ekspozisiya — pasiyentin tempinə uyğunlaşdırılmış.
3. Virtual reallıq ekspozisiyası (VRET) — uçuş, yüksəklik üçün xüsusilə uyğun.
4. Qan-inyeksiya alt-tipində — tətbiqi gərginlik metodu (ing. applied tension, Öst) — pasiyentə əzələlərini gərginləşdirmək öyrədilir, vazovaqal cavabın qarşısını alır.
5. Farmakoterapiyanın əsas rolu yoxdur; benzodiazepin yalnız konkret vəziyyət üçün (məsələn, uçuşdan öncə) qısamüddətli adjunkt kimi tətbiq edilir; bəzən KDT ekspozisiyasının səmərəliliyini azalda bilər.
6. D-sikloserin adjunkt kimi ekspozisiyanın effektivliyini gücləndirə bilər (sübutlar bazası inkişaf etməkdədir).

8.1 Müalicə metodları

1. Tək Seanslı Ekspozisiya (ing. One-Session Treatment) — Öst (Öst L.G.) — 2–3 saatlıq strukturlaşdırılmış in vivo ekspozisiya; əksər heyvan və situasiya fobiyalarında pasiyentlərin 80–90%-də effektiv nəticə əldə edilmişdir. Öst L.G. Behav Res Ther 1989.
2. Sistematik Desensibilizasiya (ing. Systematic Desensitization) — Wolpe J. — Tarixi metod — relaksasiya + tədricən fobik stimul; in vivo ekspozisiya tərəfindən üstələnmişdir.
3. Applied Tension (Öst — qan-inyeksiya) — Əzələləri 10–15 saniyə gərginləşdirmək — vazovaqal sinkop qarşısını alır; spesifik qan-inyeksiya fobiyasında.
4. Virtual Reallıq Ekspozisiya Terapiyası (ing. Virtual Reality Exposure Therapy, VRET) — Uçuş, yüksəklik, hörümçək fobiyaları üçün. Botella C. və b. icmalları.
5. D-sikloserin adjunkt — NMDA reseptorunun parsial aqonisti; ekspozisiya seansından əvvəl qəbul edildikdə sönmə (extinction) öyrənməsini gücləndirə bilər. Hofmann S.G. və b. icmalları — mülayim sübut.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Öst L.G. — bir-seanslı ekspozisiya 80–90% effektivlik nümayiş etdirir (Behav Res Ther 1989).
- Wolitzky-Taylor K.B. və b. Clin Psychol Rev 2008 meta-analiz (33 RKİ) — ekspozisiya gözləmə siyahısına qarşı böyük, plaseboya qarşı orta effekt; in vivo kontakt digər ekspozisiya formalarından üstün. Farmakoterapiya ilə müqayisə bu meta-analizdə aparılmayıb.
- APA Anxiety Guidelines — ekspozisiya birinci sıra.

9. Proqnoz

- Ekspozisiya KDT — əksəriyyət pasiyentdə remissiya.
- Müalicə olmadıqda xronikləşmə baş verir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Spesifik fobiya yalnız uşaq dövrünə aid fobiyadır, yetkinlərdə müalicə tələb etmir»

Sübut: spesifik fobiya yetkinlikdə də funksional pozulma yaradır (uçuşdan qaçınma — peşə məhdudiyyəti; tibbi prosedurların qaçınması — sağlamlıq riski).

Mif 2: «Pasiyenti fobik obyektlə üzləşdirmək travma yaradır»

Sübut: uyğun şəkildə tətbiq edilən pilləli ekspozisiya təhlükəsiz və yüksək effektivdir; pasiyentin razılığı və tempi nəzərə alınır.

Mif 3: «Hipnoterapiya və ya NLP fobiyaları sürətlə sağaldır»

Sübut: sistemli sübutlar bazası məhduddur; ekspozisiya əsaslı yanaşma qızıl standart hesab olunur.

Mif 4: «Pasiyent fobik obyektdən tam qaçınaraq normal həyat sürə bilər»

Sübut: qaçınma fobiyanı gücləndirir; situasion fobiyalar (uçuş, lift) tibbi və sosial məhdudiyyətlər yaradır.

Mif 5: «Benzodiazepin uçuş kimi spesifik vəziyyətlər üçün effektiv müalicədir»

Sübut: qısamüddətli adjunkt rolda mümkündür, lakin uzunmüddətli həll deyil; KDT/ekspozisiyanın effektivliyini azalda bilər (vəziyyətdən asılı öyrənmə — state-dependent learning).

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6B03 Xüsusi fobiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Öst L.Q. Xüsusi fobiyalar üçün birsessiyalı müalicə. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1989;27(1):1–7.
4. Volitski-Teylor K.B., Horovits C.D., Pauers M.B., Telç M.C. Xüsusi fobiyaların müalicəsində psixoloji yanaşmalar: meta-analiz. «Klinik Psixologiya İcmalı» (Clin Psychol Rev). 2008;28(6):1021–1037.
5. Hettema C.M., Nil M.K., Kendler K.S. Narahatlıq pozuntularının genetik epidemiologiyasının icmalı və meta-analizi. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2001;158(10):1568–1578.
6. Volp C. Qarşılıqlı inhibisiya yolu ilə psixoterapiya. Stanford: Stanford Universiteti Nəşriyyatı; 1958.
7. Seliqman M.E.P. Fobiyalar və hazırlıqlılıq. «Davranış Terapiyası» (Behav Ther). 1971;2(3):307–320.
8. Hofman S.Q. Translyasiya tədqiqatı perspektivindən ekspozisiyaya əsaslanan terapiyanın təkmilləşdirilməsi. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 2007;45(9):1987–2001.
9. Botella K., Fernández-Alvarez X., Gillen V. və b. Fobiyalar üçün virtual reallıq ekspozisiya terapiyasında son tərəqqi: sistematik icmal. «Müasir Psixiatriya Hesabatları» (Curr Psychiatry Rep). 2017;19(7):42.

XBT-11 **6B04**	**6B04 SOSİAL TƏŞVİŞ POZUNTUSU** **Social anxiety disorder**
XBT-10 F40.1	Sosial fobiyalar
DSM-5-TR F40.10	Sosial təşviş pozuntusu (sosial fobiya)

Sosial narahatlıq pozuntusu / 1. Tərif və nozologiya

Sosial təşviş pozuntusu (XBT-11: 6B04 Sosial narahatlıq pozuntusu; DSM-5-TR: F40.10) — sosial situasiyalarda başqaları tərəfindən mənfi qiymətləndirilməkdən və ya rüsvay olmaqdan kəskin və davamlı qorxudur. Pasiyent çıxış, qarşılıqlı təsir və müşahidə altında olmaq kimi situasiyalardan qaçır.

2. Tarixçə

- Janet P. (1903) — «phobie des situations sociales».
- Marks I.M., Gelder M.G. (1966) — sosial fobiyanın aqorafobiyadan ayrılması.
- DSM-III (1980) — «sosial fobiya» rəsmi diaqnoz kimi təsdiqlənmişdir.
- DSM-5 (2013) — «sosial narahatlıq pozuntusu» daha geniş və dəqiq termindir; yalnız çıxış situasiyaları ilə məhdudlaşan alt-tip əlavə edilmişdir. yalnız çıxış situasiyaları («yalnız çıxış zamanı») alt-tipi əlavə edilib.
- XBT-11 — paralel.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 7–13% (Kessler WMH; mədəni dəyişkənlik).
- Cins: qadınlarda nisbətən yüksək, lakin kişilər klinikaya daha çox müraciət edir.
- Başlanğıc: yeniyetməlik (orta 13 yaş) — ən erkən başlayan təşviş pozuntularındandır.
- Komorbidlik: TDP 60%, başqa narahatlıq, alkohol istifadəsi (özünü müalicə kimi).

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik təxminən 30–40%.
- Davranış inhibisiyası (ing. behavioral inhibition) (Kagan J.) — uşaqlıq temperamenti güclü risk amili.
- Neyrobioloji — amigdala hiperreaktivliyi sosial stimullar qarşısında; serotoninergik disregulasiya.
- Koqnitiv — özünə fokuslaşdırılmış diqqət, mənfi öz-imaj, fəlakətləşdirmə (catastrophizing) (Clark D.M., Wells A. modeli).
- Mühit — uşaqlıq dövründə həmyaşıdlar tərəfindən təcavüzə məruz qalma, valideynin həddindən artıq himayəsi.

5. Klinik təzahürlər

- Qorxulan situasiyalar — çıxış, sual vermə, naharın paylaşılması, başqaları qarşısında yazma və ya yemə, ictimai tualet, telefonla danışma.
- Somatik — qızarma, titrəmə, tər basması, taxikardiya, ağız quruluğu, səsin titrəməsi.

- Koqnitiv — özü haqqında mənfi düşüncələr, «situasiyadan sonrakı emal» (post-event processing) — situasiyadan sonra özünü təkrar tənqid etmə.
- Qaçınma və «təhlükəsizlik» davranışları (göz təması qaçırma, az danışma, alkohol istifadəsi).
- Funksional pozulma akademik və peşə inkişafına, dostluq və emosional münasibətlərə təsir göstərir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Bir və ya bir neçə sosial situasiyada kəskin qorxu — başqaların müşahidəsi altında olmaq və ya qiymətləndirilmək.

B. Pasiyent rüsvay olmaqdan, başqaları tərəfindən rədd edilməkdən, başqalarını incitməkdən qorxur.

C. Situasiyalar demək olar həmişə qorxu yaradır.

D. Qaçınma və ya kəskin narahatlıqla dözmə.

E. Qorxu sosial situasiyaya uyğun olmayan dərəcədə.

F. ≥ 6 ay davam edir (DSM-5-TR).

G. Funksional pozulma.

H. Başqa psixi pozuntu və ya tibbi vəziyyət ilə tam izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — «yalnız çıxış zamanı» alt-tip kvalifikatoru (yalnız çıxış-situasiyalarına məhdud).
- XBT-11 — müddət «ən azı bir neçə ay» (DSM-5-TR-də 6 ay); uşaqlarda həmyaşıdların mühiti də qiymətləndirilir (yalnız yetkin şəxslərlə məhdudlaşmır).
- NICE CG159 («Sosial təşviş pozuntusu: tanınma, qiymətləndirmə və müalicə», 2013) — fərdi KDT birinci sıra.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. SCID-5, MINI.

3. Libovits Sosial Narahatlıq Şkalası (ing. Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS) və Sosial Fobiya Sorğusu (SPIN — Social Phobia Inventory) — şkala və izləmə.
4. Komorbidlik (TDP, başqa narahatlıq, alkohol istifadəsi).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Aqorafobiya (6B02)	Qaçış çətinliyi, kömək yox; sosial qiymətləndirmə yox.
Spesifik fobiya (6B03)	Konkret obyekt/situasiya.
Panik (6B01)	Atak gözlənilməyəndir.
Avoidant şəxsiyyət pozuntusu	Davamlı model, daha geniş; komorbid sıxdır.
Autizm spektri (6A02)	Sosial-kommunikativ çatışmazlıq erkən başlanğıc; sosial maraq dəyişkən.
Selektiv mutizm (6B06)	Spesifik kontekstdə danışmama.
Bədən dismorfik pozuntu (6B21)	Görünüş əsaslı narahatlıq.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- LSAS — qızıl standart şkala (24 maddə).
- Sosial Fobiya Sorğusu (SPIN) 17 maddədən ibarət qısa skrininq vasitəsidir.
- Mənfi Qiymətləndirmə Qorxusunun Qısa Şkalası (ing. Brief Fear of Negative Evaluation, BFNE) tətbiq edilir.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG159, CANMAT 2014)

1. Fərdi KDT (Clark D.M. modeli) birinci sıra — özünə fokuslaşdırılmış diqqətin yenidən istiqamətləndirilməsi, video geribildirim (ing. video feedback), davranış eksperimentləri, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, in vivo ekspozisiya. 12–16 seans. NICE CG159 — fərdi KDT qrup KDT-dən üstün.
2. SSGİ və SNGİ birinci sıra farmakoterapiya — esitalopram, sertralin, paroksetin və venlafaksin (hamısı ABŞ-ın Qida və Dərman İdarəsi — FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir).

3. İkinci sıra — moklobemid (RIMA, Avropada təsdiqli), pregabalin (sübut məhdud), gabapentin.
4. Benzodiazepin — yalnız konkret situasiya üçün (məs. çıxış öncəsi) qısamüddətli; davamlı yox.
5. β-blokator (propranolol) — yalnız performans alt-tipində, çıxışdan 1–2 saat öncə 10–40 mq dozada, həkim nəzarəti ilə; sosial qarşılıqlı əlaqədə effektsiz.
6. Müalicə müddəti — remissiyadan sonra ≥ 12 ay.
7. Alkohol istifadəsi — özünü müalicə formasında; xüsusi diqqət və paralel müdaxilə.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Klark KDT Modeli (Clark) — Sosial təşviş üçün xüsusi inkişaf etdirilmiş; özünə fokuslaşdırılmış diqqətin xarici yönləndirilməsi, video geribildirim (ing. video feedback) (öz performansını başqalarının gözü ilə görmə), davranış eksperimentləri (qorxu inanclarının yoxlanması), in vivo ekspozisiya. Sübut: Clark D.M. və b. J Consult Clin Psychol 2003 RKİ — eksperimental fərdi KDT digər müdaxilələrdən üstün.
2. Haymberq Qrup KDT (Heimberg) — 12 seanslı qrup formatı; Heimberg R.G. modeli. Effektiv, lakin fərdi KDT-dən nisbətən zəif (NICE CG159).
3. İnternet əsaslı KDT (ing. iKDT — internet-based CBT) — Andersson G. və b. RKİ-ləri — terapist dəstəkli iCBT fərdi KDT-yə müqayisəli.
4. Libovits Sosial Təşviş Şkalası (ing. Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS) — 24 maddə (11 qarşılıqlı təsir + 13 performans); hər maddə həm qorxu/narahatlıq, həm də qaçınma üzrə qiymətləndirilir (48 qiymət, 0–144 bal və 4 altşkala); şkala əsas ölçmə vasitəsi hesab olunur.
5. Sosial Narahatlıq Sorğusu (SPIN — Social Phobia Inventory) — 17 maddə; qısa skrininq.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG159 (2013) — fərdi KDT (Clark) birinci sıra; SSGİ alternativ; qrup KDT və ya özünəyardım bəzi pasiyent üçün uyğun ola bilər.
- CANMAT 2014 — birinci sıra esitalopram, sertralin, paroksetin, venlafaksin.
- Mayo-Wilson E. və b. Lancet Psychiatry 2014 network meta-analiz — fərdi KDT ən böyük effekt; SSGİ ikinci.

9. Proqnoz

- Xronik gediş müşahidə olunur; müalicəsiz residiv riski yüksəkdir.

- KDT və SSGİ ilə əksər pasiyentlərdə əhəmiyyətli yaxşılaşma müşahidə olunur.
- Erkən başlanğıc və çəkingən (avoidant) şəxsiyyət pozuntusunun komorbidliyi əlverişsiz proqnoz göstəricisidir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Sosial narahatlıq adi utancaqlıqdır, müalicə tələb etmir»

Sübut: sosial təşviş pozuntusu funksional pozulma, akademik və peşə məhdudiyyəti, depressiya və alkohol istifadəsi riski ilə müşayiət olunur; tibbi vəziyyət kimi qiymətləndirilir.

Mif 2: «Pasiyent sosial situasiyalardan tam qaçınaraq normal həyat sürə bilər»

Sübut: qaçınma simptomları gücləndirir və izolasiyaya gətirir; ekspozisiya əsas terapevtik mexanizmdir.

Mif 3: «Alkohol sosial narahatlığı aradan qaldırır»

Sübut: alkohol qısamüddətli rahatlıq verir, lakin uzunmüddətli olaraq narahatlığı gücləndirir və alkohol istifadəsi pozuntusuna gətirir; bu komorbidliyin yayılması tədqiqatlara görə 20–40% təşkil edir.

Mif 4: «Benzodiazepin sosial narahatlıq üçün uzunmüddətli effektivdir»

Sübut: qısamüddətli effekt; asılılıq potensialı; KDT və ya SSGİ üstündür.

Mif 5: «Propranolol bütün sosial narahatlıq formaları üçün effektivdir»

Sübut: propranolol yalnız performans alt-tipində (çıxış öncəsi) effektivdir; sosial ünsiyyət situasiyalarında (toplantılar, şəxsi söhbətlər) effektsizdir.

Mif 6: «Pasiyentdə çəkingən (avoidant) şəxsiyyət pozuntusu var, ona görə müalicə nəticəsizdir»

Sübut: komorbid çəkingən şəxsiyyət pozuntusu olan pasiyent də standart müdaxilələrə cavab verə bilər; uzunmüddətli KDT və ya sxem yönümlü terapiya (ing. schema therapy) tətbiq edilir.

Mif 7: «Yalnız hipnoterapiya və ya NLP sürətlə sağaldır»

Sübut: sübut bazası yoxdur; KDT və SSGİ qızıl standart.

Mif 8: «Kanabis və kanabidiol (CBD) sosial narahatlıq üçün təhlükəsiz alternativdir»

Sübut: ilkin tədqiqatlar var, lakin klinik tövsiyə üçün kifayət deyil; tetrahidrokanabinol (THC) narahatlığı gücləndirə bilər.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşr (XBT-11). 6B04 Sosial narahatlıq pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşr, Mətn Yenidən İşlənməsi (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Sosial narahatlıq pozuntusu: tanınma, qiymətləndirmə və müalicə. NICE CG159. 2013.
4. Katzman M.A. və b. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsinin (CANMAT) 2014-cü il tövsiyələri. «BMC Psixiatriyası» (BMC Psychiatry). 2014;14(Əlavə 1):S1.
5. Mayo-Uilson E. və b. Yetkinlərdə sosial narahatlıq pozuntusunun psixoloji və farmakoloji müdaxilələri: sistematik icmal və şəbəkə meta-analizi. «Lancet Psixiatriyası» (Lancet Psychiatry). 2014;1(5):368–376.
6. Klark D.M., Elers A., MakManus F. və b. Ümumiləşmiş sosial fobiyada koqnitiv terapiya flüoksetinə qarşı: randomizə olunmuş plasebo-nəzarətli tədqiqat. «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 2003;71(6):1058–1067.
7. Libovits M.R. Sosial fobiya. «Mod Probl Pharmacopsychiatry» (Mod Probl Pharmacopsychiatry). 1987;22:141–173.
8. Heimberq R.Q., Bekker R.E. Sosial fobiya üçün koqnitiv-davranışçı qrup terapiyası. New York: Guilford Press; 2002.
9. Kaqan C., Reznik C.S., Snidman N. Uşaqlıq utancaqlığının bioloji əsasları. «Science» (Science). 1988;240(4849):167–171.
10. Uells A. Narahatlıq və depressiya üçün metakoqnitiv terapiya. New York: Guilford Press; 2009.
11. Andersson Q., Koypers P., Karlbrinq P. və b. Psixiatrik və somatik pozuntular üçün bələdçili internet əsaslı və üzbəüz koqnitiv davranış terapiyası: sistematik icmal və meta-analiz. «Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry). 2014;13(3):288–295.

XBT-11 **6B05**	**6B05 AYRILMA TƏŞVİŞİ POZUNTUSU** **Separation anxiety disorder**
XBT-10 F93.0	Uşaqlıq dövründə ayrılma narahatlığı pozuntusu
DSM-5-TR F93.0	Ayrılma təşvişi pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Ayrılma narahatlığı pozuntusu (ing. separation anxiety disorder; XBT-11: 6B05; DSM-5-TR: F93.0) — bağlanılan şəxs (tipik valideyn) və ya evdən ayrılma ilə əlaqəli inkişafa uyğun olmayan həddən artıq qorxu və narahatlıqdır. DSM-5-də ilk dəfə yetkinlərdə də diaqnoz qoyula bilər (DSM-IV-də yalnız uşaqlıq dövrü ilə məhdudlaşırdı).

2. Tarixçə

- Bowlby J. (1969–1980) — bağlanma nəzəriyyəsi.
- DSM-III (1980) — uşaqlıq pozuntusu kimi.
- DSM-5 (2013) — yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılmışdır; yetkinlərdə də diaqnoz mümkündür.

3. Epidemiologiya

- Uşaqlarda yayılma: təxminən 4%; yeniyetmələrdə təxminən 1,6%; yetkinlərdə təxminən 1,9% (Kessler R.C. NCS-R).
- Cins: qadınlarda nisbətən yüksək.
- Başlanğıc: tipik uşaqlıq (6–9 yaş); yetkin formada təkrar ortaya çıxma və ya davam etmiş forma.
- Komorbidlik: spesifik fobiya, panik, ÜTP, TDP, məktəbdən qaçınma.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik təxminən 40%.
- Bağlanma stilləri (ing. insecure attachment), valideynin həddindən artıq himayəsi.

- Yaxınlarda itki və ya xəstəlik tarixçəsi olması.
- Stress hadisələri (köç, məktəb dəyişikliyi, valideyn ayrılığı).

5. Klinik təzahürlər

- Bağlanılan şəxsə zərər və ya itki barədə həddən artıq narahatlıq.
- Evdən və ya bağlanılan şəxsdən ayrılmaqdan qaçınma.
- Tək qalmaqdan qorxu.
- Evdən kənarda yatmaqdan və ya bağlanılan şəxs yaxında olmadan yuxuya getməkdən davamlı imtina (öz yataq otağı, yad ev).
- Köç və ya ayrılma haqqında kabuslar.
- Ayrılmanı gözləyərkən somatik şikayətlər (qarın ağrısı, başağrısı, ürəkbulanma) müşahidə olunur.
- Uşaqlarda — məktəbdən qaçınma.
- Yetkinlərdə — həyat yoldaşı və ya uşaqlardan ayrılma təşvişi, həddən artıq yoxlama davranışları.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. A. Aşağıdakı simptomlardan ən azı üçü müşahidə olunmalıdır:

1. Bağlanılan şəxsdən ayrılma və ya anticipasiyasında həddən artıq narahatlıq;
2. Bağlanılan şəxsin itirilməsi və ya zərər haqqında davamlı narahatlıq;
3. Bağlanılan şəxsdən ayrılmağa səbəb olacaq hadisədən qorxu;
4. Ayrılma qorxusu səbəbi ilə evdən, məktəbdən, işdən qaçınma;
5. Bağlanılan şəxs olmadan tək qalmaqdan qorxu;
6. Bağlanılan şəxs yaxında olmadan yatmaqdan imtina;
7. Ayrılma kabusları;
8. Ayrılma anticipasiyasında somatik şikayətlər.

B. Müddət: uşaqlar/yeniyetmələrdə ≥ 4 həftə; yetkinlərdə ≥ 6 ay.

C. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

D. Başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — yetkinlərdə müddət ≥ 6 ay; uşaqlarda ≥ 4 həftə.

- XBT-11 — müddət başqa cür: «ən azı bir neçə ay»; XBT-11-də isə DSM-5-TR-dəki kimi uşaqlar üçün 4 həftə, yetkinlər üçün 6 ay bölgüsü və ayrı yaş kvalifikatoru yoxdur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (uşaqlarda valideyn ilə də).
2. Standartlaşdırılmış müsahibə (K-SADS uşaqlarda, SCID-5 yetkinlərdə).
3. Şkala — SAAS (ing. Separation Anxiety Assessment Scale).
4. Komorbidlik skrininq.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
ÜTP (6B00)	Çoxsaylı narahatlıq sahələri.
Sosial təşviş (6B04)	Sosial qiymətləndirmə dominant.
Aqorafobiya (6B02)	Qaçış çətinliyi olan situasiyalardan qaçınma.
Panik (6B01)	Atak gözlənilməyəndir.
Selektiv mutizm (6B06)	Spesifik kontekstdə danışmama.
Davranış pozuntusu (6C91) — məktəbdən qaçınma	Antisosial davranış komponenti.
Avoidant şəxsiyyət	Davamlı model bütün münasibətlərə.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- SAAS, K-SADS, MASC (ing. Multidimensional Anxiety Scale for Children).
- Komorbidlik (depressiya, başqa narahatlıq).

8. Müalicə

1. KDT (ing. uşaqlarda «Coping Cat», FRIENDS proqramları; yetkinlərdə standart KDT) — ekspozisiya əsaslı, valideyn iştirakı uşaqlarda kritik. Birinci sıra.
2. SSGİ — orta və ağır dərəcəli hallarda və ya KDT-yə cavab olmadıqda; sertralin, fluoksetin (uşaqlarda).
3. Məktəbə qayıdış proqramları (school refusal) — pilləli ekspozisiya.

4. Ailə iştirakı — valideyn psixoedukasiya, tez-tez telefon zəngləri/ziyarətlərdən qaçınma akkomodasiya simptomlarını gücləndirir (vahid yazılış bütün mətndə).

8.1 Müalicə metodikaları

1. «Coping Cat» (ing. — uşaqlar üçün qorxu ilə mübarizə proqramı) — Kendal (Kendall P.C.) — 7–13 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş KDT — 16 seans (14–17 yaş üçün C.A.T. Project), psixoedukasiya + relaksasiya + ekspozisiya + mükafatlandırma sistemi (FEAR planı).
2. FRIENDS Proqramı — Barrett (Barrett P.M.) — Avstraliyada hazırlanmışdır; uşaq və yeniyetmə təşviş pozuntularında qrup KDT.
3. Pilləli Məktəbə Qayıdış — Strukturlaşdırılmış ekspozisiya — uşaq tədricən məktəb mühitinə qayıdır; valideyn və məktəb personalı koordinasiyası.
4. Valideyn akkomodasiyasının azaldılması — SPACE (ing. Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions — Lebowitz E.) proqramı — valideynin uşağın narahatlığına akkomodasiyasının dəyişdirilməsi.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AACAP Practice Parameter (Connolly S.D., Bernstein G.A. 2007) — KDT və SSGİ uşaqlarda effektiv.
- NICE — uşaqlarda narahatlıq pozuntuları üçün ümumi göstərişlər (KDT birinci sıra).
- Walkup J.T. və b. NEJM 2008 (CAMS — Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study) — KDT ilə sertralinin kombinasiyası monoterapiyadan üstün.

9. Proqnoz

- Erkən KDT ilə əksər uşaqlarda remissiya.
- Müalicə olmadıqda vəziyyət yetkinlik dövründə başqa təşviş pozuntularına və depressiyaya keçə bilər.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Ayrılma narahatlığı pozuntusu yalnız uşaqlıqda olur»

Sübut: DSM-5-ə görə ayrılma narahatlığı pozuntusu yetkinlərdə də diaqnoz qoyulur — yayılma təxminən 1,9%.

Mif 2: «Valideyn uşağı sakitləşdirmək üçün hər tələbə cavab verməlidir»

Sübut: akkomodasiya simptomları gücləndirir; SPACE proqramı və ya valideyn təlimi tövsiyə edilir.

Mif 3: «Ayrılma narahatlığı pis tərbiyə nəticəsidir»

Sübut: irsilik təxminən 40%; bağlanma və mühit isə təsiredici amillərdir. «Pis tərbiyə» izahatı stigmatik və yanlışdır.

Mif 4: «Uşaq tək buraxılaraq „öyrəşsin“ — bu sərt yanaşma sağaldır»

Sübut: «sel ekspozisiyası» (flooding) və ya nəzarətsiz ekspozisiya travma yarada bilər; pilləli, strukturlaşdırılmış ekspozisiya tövsiyə edilir.

Mif 5: «Yalnız dərmanla sağalmaq olar»

Sübut: KDT birinci sıra; SSGİ orta-ağır halda və ya kombinasiyada.

Mif 6: «Məktəbdən qaçınma şəxsiyyət zəifliyidir, intizam tələb edir»

Sübut: məktəbdən qaçınma klinik narahatlıq simptomudur; cəza əsaslı yanaşma pozuntunu gücləndirir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşr (XBT-11). 6B05 Ayrılma narahatlığı pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşr, Mətn Yenidən İşlənməsi (DSM-5-TR). 2022.
3. Konolli S.D., Bernşteyn Q.A. Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının (AACAP) narahatlıq pozuntuları olan uşaqların və yeniyetmələrin qiymətləndirilməsi və müalicəsi üzrə Təcrübə Protokolu. «Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2007;46(2):267–283.
4. Uokap C.T. və b. CAMS: Uşaqlıq narahatlığında koqnitiv davranış terapiyası, sertralin və ya onların kombinasiyası. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2008;359(26):2753–2766.
5. Kendall P.K. Uşaqlarda narahatlıq pozuntularının müalicəsi: randomizə olunmuş klinik sınağın nəticələri. «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 1994;62(1):100–110.
6. Lebovits E.R. və b. Valideynə əsaslanan müalicə uşaqlıq narahatlığı üçün koqnitiv-davranışçı terapiya qədər effektivdir: narahat uşaqlıq emosiyaları üçün dəstəkləyici valideynlik üzrə randomizə olunmuş qeyri-aşağılıq

tədqiqatı. «Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2020;59(3):362–372.

7. Barrett P.M., Törner K. İbtidai məktəb uşaqlarında narahatlıq simptomlarının profilaktikası. «Britaniya Klinik Psixologiya Jurnalı» (Br J Clin Psychol). 2001;40(4):399–410.
8. Kessler R.K., Berqlund P., Demler O. və b. Milli Komorbidlik Tədqiqatının təkrarında DSM-IV pozuntularının həyat boyu yayılması və başlanğıc yaşının paylanması. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2005;62(6):593–602.

XBT-11 **6B06**	**6B06 SELEKTİV MUTİZM** **Selective mutism**
XBT-10 F94.0	Elektiv mutizm
DSM-5-TR F94.0	Selektiv mutizm

1. Tərif və nozologiya

Selektiv mutizm (XBT-11: 6B06; DSM-5-TR: F94.0) — uşağın dilə tam yiyələnməsinə baxmayaraq, müəyyən sosial vəziyyətlərdə (məs. məktəb) davamlı danışmaması, digər kontekstlərdə (məsələn, evdə) isə normal danışması ilə xarakterizə olunur. Tipik uşaqlıq təşviş pozuntusudur, bəzən «həddən artıq utancaqlıq» kimi yanlış qəbul edilir.

2. Tarixçə

- Kussmaul A. (1877) — «aphasia voluntaria».
- Tramer M. (1934) — «elektiv mutizm» (elective mutism) — pasiyentin könüllü seçiminin ifadəsi.
- DSM-IV (1994) — «selektiv» termini ilə əvəz edilmişdir (könüllü deyil, sosial narahatlığa görə).
- DSM-5 (2013) — təşviş pozuntuları kateqoriyasına keçirilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: 0,7–1% məktəb yaşlı uşaqlarda (Bergman R.L. və b. JAACAP 2002).
- Cins: qızlarda nisbətən yüksək (1,5–2:1).
- Başlanğıc: 2–5 yaş; adətən məktəbə başlama dövründə aşkarlanır.
- Komorbidlik: sosial təşviş pozuntusu təxminən 70%, ÜTP, başqa narahatlıq, nitq və ya dil pozuntusu.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik — ailə tarixçəsində narahatlıq sıxdır (təxminən 70% ailədə təşviş pozuntusu).
- Behavioral inhibition (Kagan) — temperamental yatkınlıq əsas amildir.
- Komorbid nitq və dil inkişaf pozuntuları (xüsusilə ikidilli mühitdə) — risk amili.
- Mühit — bilingual ailələrdə bəzən yanlış olaraq dil keçidi kimi qəbul edilir.

5. Klinik təzahürlər

- Spesifik sosial situasiyalarda (məktəb, ictimai yerlər) danışmama.
- Evdə yaxınları ilə normal danışır.
- Bəzən pıçıltı və ya jest istifadəsi.
- Akademik və sosial pozulma (sual cavablandırma, həmyaşıdları ilə münasibətlər).
- Yanaşı utancaqlıq, sosial geri çəkilmə, somatik şikayətlər.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Müəyyən sosial situasiyalarda (danışma gözlənilən) davamlı danışmama, digər vəziyyətlərdə isə nitqi normaldır.

B. Akademik, peşə və ya sosial ünsiyyətda əhəmiyyətli pozulma.

C. Müddət ≥ 1 ay (məktəbin ilk ayı ilə məhdudlaşmır).

D. Danışmama dilə yiyələnməməkdən və ya o dildə rahat olmamaqdan irəli gəlmir.

E. ünsiyyət pozuntusu (məs. axıcılıq), autizm spektri, şizofreniya və ya başqa psixotik pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — təşviş pozuntuları kateqoriyasında; «selektiv» — könüllü seçim deyil, konkret vəziyyətə xas narahatlıq cavabıdır.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Valideyn və müəllim ilə müsahibə aparılır.
2. Evdə nitq video qeydləri — diaqnoz təsdiqi.
3. SMQ (ing. Selective Mutism Questionnaire).
4. Nitq-dil qiymətləndirməsi (SLT) — ünsiyyət pozuntusu istisnası.
5. Eşitmə testi.
6. Komorbid narahatlıq, autizm, dil pozuntusu skrininq.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Dilin inkişaf pozuntusu (6A01.2)	Dil bütün kontekstlərdə zəifdir.
Autizm spektri (6A02)	Sosial-kommunikativ çatışmazlıq bütün kontekstlərdə.
İkidilli mühit — keçici haldır	Yeni dilə uyğunlaşma dövründə — adətən aylar.
Eşitmə pozuntusu	Audiometriya.
Sosial təşviş (6B04)	Komorbid sıx — pasiyent danışır, lakin sosial qiymətləndirmədən qorxur.
Travma zəminində mutizm	Travmatik hadisə tarixçəsi.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- SMQ — qızıl standart; SAS (ing. School Anxiety Scale).
- Nitq-dil qiymətləndirməsi.
- Audiometriya.

8. Müalicə

1. Davranış əsaslı yanaşma birinci sıra müalicə üsuludur — pilləli ekspozisiya, fading-in tekniki (yaxın şəxsin tədricən mühitə çıxarılması).
2. İnteqrasiyalı Davranış Terapiyası (Bergman R.L.) — protokol əsaslı; ailə və məktəbin iştirakı ilə.
3. Məktəbə əsaslanan müdaxilə — ünsiyyət tələblərinin pilləli artırılması, müəllimlərlə koordinasiya.
4. SSGİ (fluoksetin, sertralin) — orta-ağır və ya davranış müdaxiləsinə cavab verməyən hallarda. Black B. və b. JAACAP 1994 RKİ.
5. Akkomodasiya azaltma — valideynin uşağın əvəzinə danışmasının dayandırılması.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Tədricən Daxiletmə Tədricən daxil etmə texnikası (fading-in) — Pasiyent rahat olduğu şəxs ilə danışır; tədricən yad insan bu kontekstə daxil edilir; sonra pasiyent yad şəxs ilə danışmağa keçir.
2. İnteqrasiyalı Davranış Terapiyası (ing. Integrated Behavior Therapy, IBT) — Berqman (Bergman R.L.) — Pilləli ekspozisiya, müsbət gücləndirmə, sistematik desensibilizasiya; 20 seans. Sübut: Bergman R.L. və b. JAACAP 2013 RKİ.
3. Selektiv Mutizm Sorğusu (ing. Selective Mutism Questionnaire, SMQ) — Berqman (Bergman) — 17 maddə; valideyn forması.
4. SSGİ: fluoksetin — pediatrik selektiv mutizmdə sübut bazası; Black B., Uhde T.W. JAACAP 1994 RKİ.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AACAP — davranış müdaxiləsi birinci sıra üsuldur, SSGİ əlavə terapiya kimi.
- NICE — təşviş pozuntularının prinsipləri tətbiq olunur.

9. Proqnoz

- Erkən müdaxilə ilə əksər uşaqlarda nitq bərpa olunur.
- Müalicə olmadıqda xronikləşmə və sosial təşviş pozuntusuna keçid müşahidə olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Selektiv mutizm uşağın „inadkarlığı“dır»

Sübut: selektiv mutizm təşviş pozuntusudur — uşaq danışa bilmir, «danışmaq istəmir» mövqeyi yanlışdır.

Mif 2: «Uşaq danışmasa, ona güclü təzyiq lazımdır»

Sübut: təzyiq narahatlığı və mutizmi gücləndirir; pilləli ekspozisiya tövsiyə edilir.

Mif 3: «Yaşa görə keçəcək, müdaxilə tələb etmir»

Sübut: erkən müdaxilə olmadan akademik və sosial pozulma davam edir; yetkinlikdə sosial təşviş pozuntusuna keçid riski.

Mif 4: «Bilingual uşaqda mutizm normaldır»

Sübut: «sükut dövrü» (silent period) yeni dil öyrənərkən bir neçə ay normal sayılır; 1 aydan çox davam edən mutizm və ya iki dildə də olan — selektiv mutizm diaqnozu nəzərdən keçirilir.

Mif 5: «Yalnız psixoanalitik dərin terapiya effektivdir»

Sübut: davranış əsaslı və KDT yanaşmaları birinci sıra üsullardır; psixoanalitik müdaxilə sübut bazasına malik deyil.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşr (XBT-11). 6B06 Seçici mutizm. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşr, Mətn Yenidən İşlənməsi (DSM-5-TR). 2022.
3. Bergman R.L. və b. Məktəb əsaslı seçmədə seçici mutizmin yayılması və təsviri. «Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2002;41(8):938–946.
4. Bergman R.L., Qonzalez A., Piaçentini C., Keller M.L. Seçici mutizm üçün inteqrasiya olunmuş davranış terapiyası: randomizə olunmuş nəzarətli pilot tədqiqat. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 2013;51(10):680–689.
5. Blek B., Ude T.V. Elektiv mutizmin flüoksetinlə müalicəsi: ikiqat kor, plasebo-nəzarətli tədqiqat. «Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 1994;33(7):1000–1006.

6B20–6B2Z Obsessiv-kompulsiv və əlaqəli pozuntular (OKP)

Obsessiv-kompulsiv və əlaqəli pozuntular

XBT-11 **6B20**	**6B20 OBSESSİV-KOMPULSİV POZUNTU (OKP)** **Obsessive-compulsive disorder**
XBT-10 F42	Obsessiv-kompulsiv pozuntu (XBT-10: F42)
DSM-5-TR F42.2	Obsessiv-kompulsiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Obsessiv-Kompulsiv Pozuntu (OKP; XBT-11: 6B20; DSM-5-TR: F42.2) — təkrarlanan, eqo-distonik (ego-dystonic) obsessiyalar (istənilməyən, müdaxilə edən fikirlər, görüntülər, impulslar) və ya kompulsiyalar (təkrarlanan davranış və ya zehni hərəkətlər) ilə xarakterizə olunan pozuntudur. Adətən hər ikisi mövcuddur. Pasiyent narahatlığı azaltmaq və ya qorxulan nəticənin qarşısını almaq üçün kompulsiya icra edir.

DSM-5 (2013)-də OKP təşviş pozuntularından ayrı «Obsessiv-kompulsiv və əlaqəli pozuntular» (Obsessive-Compulsive and Related Disorders) kateqoriyasına keçirilmişdir; XBT-11-də də paralel dəyişiklik edilmişdir.

2. Tarixçə

- Esquirol J.E.D. (1838) — «monomanie raisonnante».
- Janet P. (1903) — «psychasthénie».
- Freud (1909) — «Rat Man» hadisəsi.
- Mowrer O.H. (1947) — ikifaktorlu öyrənmə nəzəriyyəsi (klassik şərtləndirmə + operant qaçınma); ERP-nin əsası.
- Meyer V. (1966) — Ekspozisiya (məruz qalma) və reaksiyanın qarşısının alınması (ing. Exposure and Response Prevention) (ERP) ilk klinik tətbiq.

- DSM-5 (2013) və XBT-11 (2019) — OKP təşviş pozuntularından ayrılmışdır.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 1,6–2,3% (Ruscio A.M. və b. Mol Psychiatry 2010).
- Cins: təxminən bərabər; qadınlarda daha çox yetkinlik dövründə, kişilərdə isə uşaqlıqda erkən başlanğıc müşahidə olunur.
- Başlanğıc: bimodal — pubertat öncəsi (10–12 yaş, kişilər) və erkən yetkinlik (20–25 yaş).
- Komorbidlik: TDP təxminən 60%, təşviş pozuntuları, tik pozuntuları, autizm, toplama, BDP.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 40–50% (Mataix-Cols D. və b. JAMA Psychiatry 2013).
- Neyrobioloji — kortiko-striato-talamo-kortikal (CSTC) dövrəsinin hiperaktivliyi (orbitofrontal, singulat və kaudat nüvələri); serotoninergik disregulasiya (SSGİ effekti); qlutamat disregulasiyası.
- Genetik araşdırma — SLC1A1 (qlutamat daşıyıcısı), serotonin genləri.
- PANDAS — nadir hallarda streptokokk infeksiyasından sonra OKP başlanğıcı (NIMH 2017).
- Travma, stress tətikləyici amillər.

5. Klinik təzahürlər

Tipik simptom domenləri

- Çirklənmə / təmizlik — ən sıx; əl yuma, dezinfeksiya kompulsiyaları.
- Şübhə / yoxlama — qıfıl, plitə, elektrik cihazları.
- Simmetriya / dəqiqlik / «tam yerində» (just right) — səliqə və simmetriya ilə əlaqədar.
- Aqressiv / cinsi / dini obsessiyalar — eqo-distonik, narahatlıq yaradan.
- Toplama (hoarding) — XBT-11-də ayrı kateqoriya (6B24).

Eqo-distoniya

Pasiyent obsessiyaların öz fikirləri olduğunu, lakin istənilməyən, irrasional və ya qəbuledilməz olduğunu qəbul edir (xəstəlik şüuru dəyişkəndir — DSM-5-TR xəstəlik şüuru kvalifikatorları: yaxşı / zəif / yox).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Obsessiya, kompulsiya və ya hər ikisinin mövcudluğu.

- Obsessiyalar: təkrarlanan, davamlı, istənilməyən fikirlər/görüntülər/impulslar; narahatlıq yaradır; pasiyent onları yatırmağa və ya başqa fikir və hərəkətlə neytrallaşdırmağa cəhd edir.
- Kompulsiyalar: obsessiyaya cavab olaraq və ya sərt qaydaya uyğun icra edilən təkrarlanan davranış (əl yuma, yoxlama, sıralama) və ya zehni hərəkət (sayma, dua); narahatlığı azaltmağa yönəlmiş, lakin bunlar ya realist deyil, ya da həddən artıqdır.

B. Obsessiya/kompulsiyalar gündə 1 saatdan çox vaxt aparır və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət/funksional pozulma.

C. Maddə və ya tibbi vəziyyət istisnası.

D. Başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — xəstəlik şüuru kvalifikatorları (yaxşı, orta, zəif, yox və sayıqlama səviyyəsində); tik pozuntusu ilə əlaqəli alt tip.
- XBT-11 — paralel; toplama (6B24), BDP (6B21), iy referans (6B22) ayrı kateqoriyalar.
- NICE CG31 (2005, 2019-cu il yenidən baxışı) — diaqnostika klinik müsahibə və Y-BOCS ilə.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. SCID-5, Y-BOCS (ing. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) — qızıl standart şiddət şkalası; CY-BOCS uşaqlarda.
3. OCI-R (ing. Obsessive Compulsive Inventory-Revised) — özünüqiymətləndirmə.
4. Komorbidlik (depressiya, narahatlıq, tikli, autizm, BDP, toplama).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
ÜTP (6B00)	Real həyat narahatlıqları, kompulsiyalar yox.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Tikli (8A05)	Motor/vokal; məqsədli deyil; xəbərdaredici (premonitor) hiss
BDP (6B21)	Görünüş əsaslı obsessiyalar.
Toplama (6B24)	Əşyaları atmaqda çətinlik çəkir.
Qida qəbulu pozuntuları (6B80–6B8Z)	Yemə davranışı əsas.
Trikotilomania (6B25.0), dermatilomania (6B25.1)	Bədənə yönəlmiş təkrar davranış.
Obsessiv-kompulsiv (anankastik) şəxsiyyət pozuntusu (XBT-11: 6D11.4)	Davamlı şəxsiyyət modeli, eqo-sintonik xarakter daşıyır; OKP eqo-distonik.
Şizofreniya / sayıqlama pozuntusu	Sayıqlama səviyyəsində xəstəlik şüuru; OKP-də xəstəlik şüuru dəyişkəndir.
Autizm spektri	Məhdud-təkrarlanan davranış; eqo-sintonik.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Y-BOCS / CY-BOCS — qızıl standart.
- OCI-R — özünüqiymətləndirmə.
- Komorbidlik (depressiya, narahatlıq).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG31, APA, WFSBP)

1. Birinci sıra psixoterapiya: ERP — ekspozisiya və reaksiyanın qarşısının alınması (ing. exposure and response prevention) — pasiyent qorxulan obyekt/situasiyaya məruz qalır və kompulsiyanı icra etmir. 12–20 seans. Sübut: Foa E.B. və b. RKİ-ləri; effekt böyük.
2. Birinci sıra farmakoterapiya: SSGİ yüksək dozada — fluoksetin (40–80 mq), sertralin (200 mq), paroksetin (40–60 mq), fluvoksamin (200–300 mq), essitalopram (20–40 mq). OKP-də standart depressiya dozasından yüksək doza tələb olunur; effekt 8–12 həftə ərzində görünür (depressiyaya nisbətən gec).
3. KDT/ERP ilə SSGİ kombinasiyası — ERP-nin öz effektindən üstün deyil: Foa E.B. və b. Am J Psychiatry 2005 RKİ-də (n=122, klomipramin) ERP və ERP+klomipramin fərqlənmədi, hər ikisi tək klomipramindən üstün idi

(cavab 62–86% ERP, 70–79% kombinasiya, 42–48% klomipramin, 8–10% plasebo). Güclü komponent ERP-dir; farmakoterapiya ERP əlçatan olmadıqda və ya komorbidlik üçün əlavə olunur.

4. Klomipramin (TCA) — birinci sıra alternativdir; SSGİ-yə cavab olmadıqda istifadə olunur; antikolinergik və kardial yan təsirlər.
5. Gücləndirmə (SSGİ ilə birlikdə aşağı dozada atipik antipsixotik) — risperidon, aripiprazol; refrakter hallarda. — risperidon, aripiprazol; refrakter halda.
6. Refrakter ağır OKP: Dərin beyin stimulyasiyası (ing. DBS; deep brain stimulation) — hədəf: ventral kapsul və ventral striatum, neyrocərrahiyyə (kapsulotomiya, singulotomiya); EKT effektsiz; ketamin/esketamin sürətli effekt tədqiqatları davam edir.
7. Müalicə müddəti — uzunmüddətli; remissiyadan sonra ≥ 1–2 il, çoxsaylı residiv halda ömürlük.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Ekspozisiya və Reaksiyanın Qarşısının Alınması (ing. Exposure and Response Prevention, ERP) — Meyer (Meyer V.), Foa (Foa E.B.) — Pasiyent qorxulan obyektə (məs. «çirkli» əşya) məruz qalır və kompulsiyanı (əl yumaq) icra etmir; narahatlıq tədricən azalır (vərdiş halına düşmə — habitualization). Standart kurs 12–20 seans, həftədə 1–2 dəfə; daha intensiv format (gündəlik) effektivdir. Sübut: Foa E.B. və b. Am J Psychiatry 2005.
2. KDT — koqnitiv komponent — ERP-yə əlavə; obsessiya haqqında düşüncələrin yenidən qiymətləndirilməsi; «fikir-hərəkət birləşməsi» (thought-action fusion; TAF) və hiperməsuliyyət koqnisiyalarına yönəlir.
3. Yale-Braun Obsessiv-Kompulsiv Şkalası (ing. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Y-BOCS) — Qudman (Goodman W.K.) — 10 maddə; 5 obsessiya + 5 kompulsiya; qızıl standart; CY-BOCS uşaqlarda.
4. SSGİ Yüksək Doza — OKP-də standart depressiya dozasından əhəmiyyətli yüksək doza tələb olunur; titrasiya 8–12 həftə; cavabsızlıqda doza maksimuma çatdırılır.
5. Klomipramin (TCA) — OKP-də sübut güclü (CMI multicenter trial 1991); kardial və antikolinergik yan təsirlər; ikinci sıra.
6. Dərin Beyin Stimulyasiyası (ing. DBS — Deep Brain Stimulation) — Refrakter ağır OKP-də cərrahi müdaxilə; ventral kapsul və ventral striatum hədəfi. Greenberg B.D. və b. Mol Psychiatry 2010.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG31 (2005, 2019 surveillance) — pilləli yanaşma şiddətə görə; ERP birinci sıra; SSGİ orta-ağır.
- APA-nın OKP üzrə təcrübə təlimatı (2007) — eyni; klomipramin sübut bazasına görə güclü, lakin yan təsirə görə ikinci sıra.
- WFSBP (Bandelow B. və b. 2008) — SSGİ doza diapazonları və titrasiya.
- PANDAS üzrə NICE CG31-də tövsiyə yoxdur; sübut bazası olmadığından rutin antibiotik profilaktikası məsləhət görülmür.

9. Proqnoz

- Xronik gedişat müşahidə olunur, lakin adekvat müalicə ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma əldə edilir.
- Komorbid depressiya, tikli, autizm pis proqnoz göstəricisidir.
- Erkən başlanğıc və zəif xəstəlik şüuru — daha çətin müalicə.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «OKP — sadəcə təmizlik və səliqə ilə əlaqədar şəxsiyyət xüsusiyyətidir»

Sübut: klinik OKP eqo-distonik, narahatlıq doğuran və funksional pozulma yaradan; anankastik şəxsiyyət pozuntusu (6D11) eqo-sintonik fərqli pozuntudur. Diaqnoz Y-BOCS şiddəti və xəstəliyin müddəti əsasında qoyulur.

Mif 2: «Pasiyent iradi olaraq obsessiyaları „dayandıra bilər“»

Sübut: OKP CSTC dövrəsinin tənzimlənməsinin pozulmasıdır; iradi idarə olunmur; ERP və SSGİ neyrobioloji səviyyədə təsir edir.

Mif 3: «SSGİ depressiya dozasında OKP-də effektivdir»

Sübut: OKP-də SSGİ yüksək dozada (fluoksetin 60–80 mq, sertralin 200 mq) tələb olunur; depressiya dozası (məs. fluoksetin 20 mq) çox vaxt cavab vermir.

Mif 4: «ERP travma yaradır, çünki pasiyenti qorxulu situasiyada saxlayır»

Sübut: ERP strukturlaşdırılmış, pilləli və pasiyentin razılığı ilə həyata keçirilir; uzunmüddətli sübutlu effektivlik göstərir.

Mif 5: «PANDAS OKP-nin əsas səbəbidir, hamı antibiotika almalıdır»

Sübut: NIMH 2017 — PANDAS nadir hadisədir; rutin antistreptolizin-O (ASO) titrinin təyini və antibiotik profilaktikası tövsiyə edilmir; yalnız klassik klinik mənzərə olduqda.

Mif 6: «Kompulsiyaları icra etməyə icazə vermək simptomları sakitləşdirir»

Sübut: kompulsiyalara icazə (akkomodasiya) OKP-ni gücləndirir; ailə akkomodasiyasının azaldılması müalicənin vacib komponentidir.

Mif 7: «Bitki preparatları (dəvədabanı, kava, omeqa-3) OKP simptomlarını müalicə edir»

Sübut: heç birinin OKP-də sübutlu effekti yoxdur; dəvədabanı SSGİ ilə qarşılıqlı təsir riski yaradır.

11. Ədəbiyyat

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşr (XBT-11). 6B20 Obsesif-kompulsiv pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NICE CG31. Obsesiv-kompulsiv pozuntu və bədən dismorfik pozuntusu. 2005, 2019-cu il nəzarət baxışı.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Obsesiv-kompulsiv pozuntu olan xəstələrin müalicəsi üzrə Təcrübə Rəhbərliyi. 2007.
5. Bandelov B. və b. Təşviş, obsesiv-kompulsiv və posttravmatik stress pozuntularının farmakoloji müalicəsi üzrə Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) rəhbərlikləri. «Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Jurnalı» (World J Biol Psychiatry). 2008;9(4):248–312.
6. Foa E.B., Libovits M.R., Kozak M.C. və b. Obsesiv-kompulsiv pozuntunun müalicəsində ekspozisiya və ritualın qarşısının alınması, klomipramin və onların kombinasiyasının randomizə edilmiş, plasebo nəzarətli sınağı. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2005;162(1):151–161.
7. Rusio A.M., Stein D.C., Çiu V.T., Kesler R.C. Milli Komorbidlik Tədqiqatının Təkrarında obsesiv-kompulsiv pozuntunun epidemiologiyası. «Molekulyar Psixiatriya» (Mol Psychiatry). 2010;15(1):53–63.
8. Matayks-Kols D. və b. Obsesiv-kompulsiv pozuntunun ailə riskləri. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2013;70(7):709–717.

9. Qrinberq B.D. və b. Obsesiv-kompulsiv pozuntu üçün ventral daxili kapsulun/ventral striatumun dərin beyin stimulyasiyası. «Molekulyar Psixiatriya» (Mol Psychiatry). 2010;15(1):64–79.
10. ABŞ Milli Ruhi Sağlamlıq İnstitutu (NIMH). həkimlər üçün PANDAS/PANS məlumatı. 2017.
11. Qudman V.K., Prays L.H., Rasmussen S.A. və b. Yel-Braun Obsesiv-Kompulsiv Şkalası. I. Hazırlanması, istifadəsi və etibarlılığı. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 1989;46(11):1006–1011.

XBT-11 **6B21**	**6B21 BƏDƏN DİSMORFİK POZUNTUSU (BDP)** **Body dysmorphic disorder**
XBT-10 F45.2	Hipoxondrik pozuntu
DSM-5-TR F45.22	Bədən dismorfik pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Bədən Dismorfik Pozuntusu (BDP; XBT-11: 6B21; DSM-5-TR: F45.22) — pasiyentin görünüşündəki real olmayan və ya çox kiçik qüsurla bağlı obsessiv məşğuliyyətdir; bu məşğuliyyət təkrarlanan davranışlara (güzgüyə baxma, dəri qaşıma, kosmetik prosedurlar axtarışı) və ya zehni hərəkətlərə (müqayisə) gətirir.

2. Tarixçə

- Morselli E. (1891) — «dismorfofobiya» (ing. dysmorphophobia).
- DSM-III-R (1987) — «Bədən dismorfik pozuntusu» somatoform pozuntular qrupuna daxil edilmişdi.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 — obsessiv-kompulsiv spektr kateqoriyasına keçirilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Ümumi əhalidə yayılma: 1,7–2,4% (Buhlmann U. və b. Psychiatry Res 2010).
- Kosmetik dermatoloji və plastik cərrahiyə klinikalarında 9–15%.

- Cins: təxminən bərabər.
- Başlanğıc: orta 15–16 yaş.
- Komorbidlik: TDP təxminən 75%, OKP təxminən 30%, sosial narahatlıq təxminən 37%, maddə istifadəsi.
- İntihar (suisid) riski yüksəkdir: cəhd təxminən 24–28%, tamamlanmış intihar hallarının sayı əhalidən 45 dəfə yüksəkdir (Phillips K.A. icmalları).

4. Etiologiya və patogenez

- Genetik üst-üstə düşmə OKP ilə.
- Neyrobioloji — orbitofrontal-striatal dövrə hiperaktivliyi (OKP-yə bənzər); vizual emal pozulması (Feusner J.D. və b. icmalları — pasiyent detallara həddindən artıq fokuslanır, ümumi görüntünü inteqrasiya etmir).
- Sosial-mədəni — kütləvi mediada idealizə edilmiş görünüş.
- Uşaqlıqda yaşıdlarla münasibətdə viktimizasiya (rüsvayetmə, zorbalıq) halları müşahidə olunur.

5. Klinik təzahürlər

- Görünüşün konkret hissəsinə (üz, dəri, saç, burun, bədən forması) obsessiv fokus.
- Real qüsur yoxdur və ya başqaları üçün görünməz/əhəmiyyətsizdir.
- Təkrarlanan davranışlar: güzgüyə baxma, dəri qaşıma, müqayisə, kosmetik prosedur axtarışı, geyim/makyaj/kamuflyaj.
- Zehni hərəkətlər: özünü başqaları ilə müqayisə.
- Xəstəlik şüuru (ing. insight) çox vaxt zəifdir; bəzən sayıqlama səviyyəsində.
- «Əzələ dismorfiyası» alt-tipi — kişilərdə əzələnin «kifayət qədər inkişaf etməməsi» obsessiyası; anabolik steroid istifadəsinə gətirir.
- Yüksək sosial təcrid, akademik və peşə pozulması.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Görünüşdəki qüsur və ya nöqsan üzərində məşğuliyyət; başqaları üçün görünməz və ya kiçikdir.

B. Pasiyent hər hansı mərhələdə təkrarlanan davranış (güzgüyə baxma, dəri qaşıma, həddindən artıq geyinmə-dəyişmə) və ya zehni hərəkət (müqayisə) icra etmişdir.

C. Məşğuliyyət əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma yaradır.

D. Qida qəbulu pozuntusu meyarına çatan bədən obrazı ilə məşğuliyyət olmamalıdır (anoreksiya/bulimiya).

Kvalifikatorlar: əzələ dismorfiyası (muscle dysmorphia) ilə gediş; xəstəlik şüuru (yaxşı / orta — zəif / yox / sayıqlama).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — OKP spektri kateqoriyasında; əzələ dismorfiyası kvalifikatoru.
- NICE CG31 — BDP və OKP birgə tövsiyələr.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (pasiyent çox vaxt utancdan açıq danışmır).
2. Bədən dismorfik pozuntu sorğusu (BDPS) — skrininq.
3. BDP-YBOCS — şiddət şkalası.
4. Komorbidlik (TDP, OKP, sosial narahatlıq pozuntusu, İntihar riski).
5. Anabolik steroid və ya kosmetik prosedur tarixçəsi.

6.4 Differensial diaqnostika (cədvəl 1)

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
OKP (6B20)	Obsessiyalar görünüşlə məhdud deyil.
Qida qəbulu pozuntuları (6B80–6B85)	Çəki və forma əsas; yemə davranışı pozulmuşdur.
Sayıqlama pozuntusu (6A24)	Xəstəlik şüuru yox; BDP-də çox vaxt dəyişkəndir.
Sosial narahatlıq pozuntusu (6B04)	Sosial qiymətləndirmə geniş; BDP-də spesifik görünüş hissəsinə fokus.
Trikotilomania (6B25.0)	Saç çəkmə əsas; görünüş narahatlığı ikincili.
Bədən qoxusunun referens pozuntusu (6B22)	İy əsaslı.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- BDDQ — skrininq (Phillips K.A.).

- BDP-YBOCS — uyğunlaşdırılmış OKP şkalası, 12 maddə.
- C-SSRS — intihar riski (yüksək).

8. Müalicə

1. Birinci sıra psixoterapiya: KDT (BDP-yə uyğunlaşdırılmış, Wilhelm S., Phillips K.A.) — koqnitiv yenidənqurma, ekspozisiya + güzgü ilə yenidən təlim + davranış eksperimentləri. 12–22 seans.
2. Birinci sıra farmakoterapiya: SSGİ yüksək dozada — OKP-yə bənzər; fluoksetin (40–80 mq), esitalopram (10–20 mq), sertralin (150–200 mq).
3. Klomipramin — alternativ.
4. Augmentasiya — atipik antipsixotik (xüsusən sayıqlama səviyyəsində xəstəlik şüuru).
5. Müalicə müddəti uzun; remissiyadan sonra ≥ 1–2 il.
6. İntihar riski mütəmadi olaraq izlənir.
7. Kosmetik prosedurların qarşısının alınması — pasiyent dermatoloq və plastik cərrahla əməkdaşlıq etməlidir; sübut: cərrahi prosedur BDP simptomlarını yaxşılaşdırmır, çox vaxt yeni fokus yaradır (Crerand C.E. və b. Ann Plast Surg 2010;65(1):11–16).

8.1 Müalicə metodikaları

1. BDP üçün KDT — Vilhelm (Wilhelm S.), Fillips (Phillips K.A.) — standartlaşdırılmış 22 seanslı protokol — psixoedukasiya, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, güzgü yenidən təlim (ing. mirror retraining), davranış eksperimentləri, ritualın qarşısının alınması (ERP), residiv profilaktikası.
2. Bədən Dismorfik Pozuntu Sorğusu (ing. Body Dysmorphic Disorder Questionnaire, BDDQ) — Fillips (Phillips K.A.) skrininq üçün istifadə olunur.
3. BDP-YBOCS — OKP üçün Y-BOCS-un BDP-yə uyğunlaşdırılması.
4. SSGİ Yüksək Doza — OKP-yə bənzər; cavab 8–12 həftə.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE (Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu) CG31 rəhbərliyi — KDT və yüksək dozada SSGİ birinci sıra müalicədir.
- Phillips K.A. tədqiqatları — SSGİ-lər BDP-də effektiv; yüksək doza, uzunmüddətli.

9. Proqnoz

- Xronik gediş.
- Adekvat müalicə ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma; remissiya mümkündür, lakin uzunmüddətli saxlama tələb olunur.
- Suicid riski izlənir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «BDP pasiyenti „həqiqi qüsur“u var, kosmetik cərrahiyə kömək edər»

Sübut: Crerand C.E. Ann Plast Surg 2010 — kosmetik prosedurlar BDP-ni yaxşılaşdırmır; pasiyentlərin əksər hissəsi nəticədən narazıdır və ya yeni fokus inkişaf edir. Cərrahların BDP skrininqi etmələri tövsiyə olunur.

Mif 2: «BDP pasiyentinin görünüşünü təriflə „rahatlatmaq“ lazımdır»

Sübut: təriflər və ya inkar (təskinlik) qısamüddətli rahatlıq verir, lakin obsessiyanı gücləndirir; ailə akkomodasiyasının azaldılması müalicə komponentidir.

Mif 3: «BDP adi „özünə inamsızlıq“dır»

Sübut: BDP funksional pozulma və yüksək intihar riski ilə müşayiət olunur (cəhd 24 –28%, əhalidən 45 dəfə yüksək); klinik vəziyyət kimi qiymətləndirilir.

Mif 4: «SSGİ depressiya dozasında BDP-də effektivdir»

Sübut: OKP-yə bənzər — yüksək doza tələb olunur; cavab 8–12 həftə.

Mif 5: «Əzələ dismorfiyası qadın pozuntusu deyil, kişilərdə də olmur, sadəcə fitness motivasiyasıdır»

Sübut: əzələ dismorfiyası kişilərdə də yayılmışdır; anabolik steroid istifadəsi, kompulsiv idman, sosial təcrid və depressiya ilə müşayiət olunur; DSM-5-TR-də kvalifikator.

Mif 6: «Plastik cərrahdan ardıcıl prosedur axtarmaq normaldır»

Sübut: ardıcıl prosedurlar BDP-nin əlamətidir; cərrah BDP skrininq edib psixiatra yönəltməlidir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B21 Bədən dismorfik pozuntusu. 2024.

2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NICE CG31. 2005, 2019-cu il nəzarət baxışı.
4. Filips K.A. Sınıq güzgü: Bədən dismorfik pozuntusunun anlaşılması və müalicəsi. Oksford Universiteti Nəşriyyatı; 2005.
5. Vilhelm S., Filips K.A., Steketi Q. Bədən dismorfik pozuntusu üçün koqnitiv-davranış terapiyası: Müalicə təlimatı. Guilford Nəşriyyatı (ing. Guilford Press); 2013.
6. Bulmann U. və b. Bədən dismorfik pozuntusunun yayılması üzrə yenilənmələr: əhali (populyasiya) əsaslı sorğu. «Psixiatriya Tədqiqatları» (Psychiatry Res). 2010;178(1):171–175.
7. Krerand K.E., Menard V., Filips K.A. Bədən dismorfik pozuntusu olan şəxslərdə cərrahi və minimal invaziv kosmetik prosedurlar. «Plastik Cərrahiyyə İlliyi» (Ann Plast Surg). 2010;65(1):11–16.
8. Feusner C.D., Taunsend C., Bistritski A., Bukhaymer S. Bədən dismorfik pozuntusunda üzlərin vizual informasiya emalı. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2007;64(12):1417–1425.

XBT-11 **6B22**	**6B22 BƏDƏNİN QOXUSU POZUNTUSU** **Olfactory reference disorder**
XBT-10 F45.8	Digər somatoform pozuntular
DSM-5-TR F42.8	Digər dəqiqləşdirilmiş obsessiv-kompulsiv və əlaqəli pozuntu (olfaktor referens sindromu)

1. Tərif və nozologiya

Bədənin qoxusu pozuntusu (BQP) (ing. XBT-11: 6B22 Olfactory Reference Disorder; DSM-5-TR: F42.8 Other Specified Obsessive-Compulsive and Related Disorder) — pasiyentin bədənindən real olmayan və ya həddindən artıq qiymətləndirilmiş pis iy yayması haqqında obsessiv inamla xarakterizə olunan pozuntudur. Pasiyent başqalarının onu qınamasını və ya rüsvay etməsini düşünür, kompulsiv yuyunma, deodorant istifadəsi, sosial qaçınma davranışı göstərir.

2. Tarixçə

- Pryse-Phillips W. (1971) — «olfactory reference syndrome» termini.
- DSM-IV — ayrı kateqoriya yox idi (Sayıqlama pozuntusu somatik alt-tip kimi).
- DSM-5 (2013) — OKP spektrinə aid pozuntu kimi qeyd edilmişdir; lakin ayrı kod təyin edilməyib.
- XBT-11 (2019) — ilk dəfə rəsmi diaqnostik kateqoriya kimi müəyyən edilmişdir (6B22).

3. Epidemiologiya

- Yayılma: dəqiq epidemioloji məlumat məhduddur; klinik və icmal hesabatlarına görə nadir, lakin çox vaxt diaqnoz qoyulmadan qalır (Phillips K.A., Menard W. Gen Hosp Psychiatry 2011).
- Başlanğıc: erkən yetkinlik (orta 20–25 yaş).
- Cins: təxminən bərabər.
- Komorbidlik: TDP, sosial narahatlıq, OKP, BDP, intihar riski yüksək (intihar fikirləri təxminən 68%, cəhd təxminən 32% — Phillips K.A., Menard W. Gen Hosp Psychiatry 2011, n=20).

4. Etiologiya və patogenez

- Genetik və neyrobioloji üst-üstə düşmə OKP və BDP ilə.
- Xəstəlik şüuru dəyişkəndir — bəzən sayıqlama səviyyəsində.
- Sosial-mədəni amillər — bədən iyi haqqında sosial stiqma.

5. Klinik təzahürlər

- Bədən iyi (ağız, qoltuqaltı, ayaq, genital nahiyə, bütün bədən) və ya nəfəs iyi haqqında obsessiv məşğuliyyət.
- Başqalarının reaksiyasını «yanlış olaraq oxuma» (referent fikirlər) — öskürmə, burnu qaşıma, pəncərə açma «iyin əlaməti» kimi şərh olunur.
- Kompulsiv davranışlar — tez-tez yuyunma, paltar dəyişmə, deodorant, ətr, ağız təmizliyi, saqqız çeynəmə, tez-tez diş fırçalama.
- Sosial qaçınma — iş və məktəbdən qaçınma, sosial təcrid.
- Kompensator davranışlar — başqalarından məsafə saxlama.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (XBT-11)

A. Pasiyentin bədənindən pis iy yayıldığı və ya nəfəsdə pis iy olduğu haqqında davamlı məşğuliyyət — başqaları tərəfindən ya hiss olunmur, ya da çox zəif hiss olunur.

B. Pasiyent obsessiyaya cavab olaraq təkrarlanan davranışlar (yuyunma, qoxu maskalama, dəri yoxlanması) və ya zehni hərəkətlər (özünü başqaları ilə müqayisə) icra edir.

C. Məşğuliyyət əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma yaradır.

D. Maddə və ya tibbi vəziyyət (real halitoz, hipergidroz, trimetilaminuriya, qoxu mübadiləsinin metabolik pozuntuları) istisnası.

Xəstəlik şüuru kvalifikatoru: yaxşı / orta — zəif / yox / sayıqlama səviyyəsində.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 — ayrı kateqoriya kimi rəsmiləşdirilib.
- DSM-5-TR — «Digər dəqiqləşdirilmiş obsessiv-kompulsiv və əlaqəli pozuntu» daxilində.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Tibbi və otorinolarinqoloji müayinə — real halitoz, sinüsit, hipergidroz, mədə-bağırsaq xəstəlikləri istisnası.
3. Trimetilaminuriya (TMAU) sidikdə trimetilaminin təyini ilə təsdiqlənir (nadir genetik metabolik pozuntu, «balıq qoxusu sindromu»).
4. Xəstəlik şüuru səviyyəsi qiymətləndirməsi.
5. Komorbidlik və intihar riski (yüksək).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Real halitoz / hipergidroz / TMAU	Obyektiv təsdiq olunmuş.
BDP (6B21)	Görünüş əsaslı.
OKP (6B20)	Çoxsaylı obsessiyalar.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Sayıqlama pozuntusu (6A24) — somatik	Xəstəlik şüuru yox; klinik təzahürlər üst-üstə düşür.
Şizofreniya	Digər psixotik simptomlar.
Sosial qorxu (6B04)	Sosial qiymətləndirmə qorxusu geniş.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Tibbi müayinə stomatoloji, otorinolarinqoloji (LOR) və mədə-bağırsaq sahəsini əhatə edir.
- TMAU testi (sidik trimetilamin).
- Şkala — spesifik şkala yoxdur; Y-BOCS uyğunlaşdırılmış formada istifadə olunur.
- C-SSRS (yüksək intihar riski).

8. Müalicə

1. KDT — OKP/BDP-yə uyğun yanaşma; ekspozisiya (qoxu yoxlama davranışının dayandırılması, sosial situasiyaya qayıdış), koqnitiv yenidən strukturlaşdırma.
2. SSGİ yüksək dozada — OKP-yə bənzər.
3. Augmentasiya — atipik antipsixotik (sayıqlama səviyyəsində xəstəlik şüuru).
4. Sosial reabilitasiya.
5. Suicid riski izlənməsi.

8.1 Müalicə metodikaları

1. KDT (OKP/BDP-yə uyğunlaşdırılmış) ekspozisiya, ritualların qarşısının alınması və koqnitiv yenidənqurma.
2. SSGİ Yüksək Doza — OKP-yə bənzər; 8–12 həftə.

9. Proqnoz

Sübut bazası məhduddur. SSGİ + KDT ilə yaxşılaşma; intihar riski izlənir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pasiyent həqiqətən pis iyli ola bilər — əvvəlcə tibbi yoxlama olmadan psixiatrik diaqnoz qoyula bilməz»

Sübut: bu inanc qismən doğrudur — tibbi səbəblər (halitoz, hipergidroz, TMAU) mütləq istisna edilməlidir; lakin tibbi səbəb yoxdursa və obsessiv məşğuliyyət davam edirsə, klinik vəziyyət bədənin qoxusu pozuntusudur.

Mif 2: «Tez-tez yuyunma və deodorant istifadəsi problemi həll edir»

Sübut: kompulsiv davranışlar qısamüddətli rahatlıq verir, lakin pozuntunu gücləndirir; dəri irritasiyası, sosial pozulma artır.

Mif 3: «Pasiyent yalnız özünüqiymətləndirmə problemi yaşayır»

Sübut: klinik pozuntudur; intihar riski yüksəkdir (intihar fikirləri təxminən 68%, cəhd təxminən 32%); tibbi müdaxilə tələb olunur.

Mif 4: «Yalnız antipsixotik effektivdir, çünki sayıqlamadır»

Sübut: xəstəlik şüuru dəyişkəndir; SSGİ yüksək doza + KDT birinci sıra; antipsixotik augmentasiya yalnız sayıqlama səviyyəsində.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B22 Olfaktor referens pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Filips K.A., Menard V. Olfaktor referens sindromu: təsəvvür edilən bədən qoxusunun demoqrafik və klinik xüsusiyyətləri. «Ümumi Xəstəxana Psixiatriyası» (Gen Hosp Psychiatry). 2011;33(4):398–406.
4. Prays-Filips V. Olfaktor referens sindromu. «Skandinav Psixiatriya Aktası» (Acta Psychiatr Scand). 1971;47(4):484–509.

XBT-11 **6B23**	**6B23 HİPOXONDRİYA** **Hypochondriasis**
XBT-10 F45.2	Hipoxondrik pozuntu
DSM-5-TR F45.21	Xəstəlik narahatlığı pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Hipoxondriya (XBT-11: 6B23 Hypochondriasis; DSM-5-TR: F45.21 Illness Anxiety Disorder — yeni adı, somatik simptom pozuntusundan ayrılaraq) — ciddi tibbi xəstəliyin olması və ya inkişaf etməsi ilə bağlı davamlı məşğuliyyət və narahatlıq. Pasiyent təkrarlanan tibbi yoxlamalar (klinik müraciət, internetdə tibbi məlumat axtarışı (kiberxondriya), dostlardan məsləhət) və ya əksinə tibbi qaçınma davranışı göstərir.

DSM-5 (2013)-də hipoxondriya diaqnozu iki yeni kateqoriyaya bölünmüşdür:

- Somatik simptom pozuntusu (F45.1) — somatik şikayətlər mövcuddur;
- Xəstəlik narahatlığı pozuntusu (F45.21) — somatik simptomlar minimal və ya yoxdur, narahatlıq üstünlük təşkil edir.

XBT-11 (2019) — hipoxondriya OKP spektrinə daxil edilmişdir (somatoform pozuntulardan ayrılaraq) — bu konseptual keçid sübut bazasını əks etdirir (OKP-yə bənzər neyrobiologiya və müalicə cavabı).

2. Tarixçə

- Yunan tibbi — «hipoxondrium» (qabırğaaltı nahiyə) — qədim humoral nəzəriyyə.
- DSM-III (1980) — somatoform pozuntular kateqoriyasında.
- DSM-5 (2013) — xəstəlik narahatlığı pozuntusu və somatik simptom pozuntusunun ayrılması.
- XBT-11 (2019) — OKP spektri kateqoriyasına keçid.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 1–6% (Bleichhardt G., Hiller W. Br J Health Psychol 2007).
- İlkin tibbi yardım pasiyentlərində: təxminən 3–10%.
- Cins: təxminən bərabər.
- Başlanğıc: erkən–orta yetkinlik.
- Komorbidlik: TDP, ÜTP, OKP, panik pozuntu.

4. Etiologiya və patogenez

- Genetik üst-üstə düşmə OKP və narahatlıq pozuntuları ilə genetik üst-üstə düşmə müşahidə olunur.
- Uşaqlıqda travma və ya tibbi xəstəlik təcrübəsi olmuşdur.

- Koqnitiv — bədən sensasiyalarının fəlakətli şərh edilməsi; selektiv diqqət; «tibbi məlumat axtarışı» (cyberchondria).
- Modelləşdirmə — ailədə xəstəliyə yüksək həssaslıq.

5. Klinik təzahürlər

- Ciddi xəstəliyin (xərçəng, ürək tutması, müxtəlif xronik xəstəliklər) inkişafından qorxu müşahidə olunur.
- Normal bədən sensasiyalarının (ürək döyüntüsü, başağrısı, ləng bağırsaq) ciddi xəstəliyin əlaməti kimi şərh edilməsi.
- Davranış modelləri (iki qütb):
    - Yardım axtaran davranış (care-seeking) — təkrar tibbi müayinə, çoxsaylı həkim müraciəti («həkimdən həkimə müraciət»), internet axtarışı (cyberchondria), bədən yoxlamaları.
    - Yardımdan qaçan davranış (care-avoiding) — tibbi yoxlamalardan qaçınma (qorxu sübutu eşitmək), xəstəxanadan və tibbi cihazlardan qaçınma.
- Tibbi təskinlik qısamüddətli rahatlıq verir, sonra narahatlıq qayıdır.
- Funksional pozulma — işdən qalma, sosial təcrid.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Ciddi xəstəliyin olması və ya inkişaf etməsi ilə bağlı məşğuliyyət.

B. Somatik simptomlar minimal və ya yoxdur; mövcuddursa, onlar məşğuliyyətin şiddətinə uyğun olmur.

C. Sağlamlıqla bağlı yüksək narahatlıq.

D. Pasiyent sağlamlıqla bağlı həddindən artıq davranışlar (yoxlama) və ya xəstəlik qaçınması.

E. Davametmə müddəti ≥ 6 ay (DSM-5-TR); xəstəliyin tipik məzmunu zaman ərzində dəyişə bilər.

F. Başqa psixi pozuntu (TDP, panik, ÜTP, OKP, BDP, sayıqlama somatik) ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — Illness Anxiety Disorder (F45.21); yardım axtaran və yardımdan qaçan alt tiplər.

- XBT-11 — OKP spektri kateqoriyasında (6B23); klassik somatoform pozuntular qrupundan fərqli olaraq OKP spektrinə daxil edilmişdir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Tibbi qiymətləndirmə — real xəstəliyin istisnası (lakin həddindən artıq müayinədən qaçınılmalıdır).
3. Şkala — Uaytli İndeksi və SHAI (Qısa sağlamlıq narahatlığı sorğusu).
4. Komorbidlik skrininq.

6.4 Differensial diaqnostika (cədvəl 3)

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Somatik simptom pozuntusu (6C20)	Somatik şikayətlər dominant.
Real tibbi xəstəlik	Klinik və laboratoriya müayinələri ilə təsdiqlənir.
OKP (6B20)	Çoxsaylı obsessiyalar; məşğuliyyət yalnız xəstəliklə məhdudlaşmır.
ÜTP (6B00)	Çoxsaylı narahatlıq sahələri.
Panik (6B01)	Hücum dövründə «ürək tutması» qorxusu.
Sayıqlama pozuntusu (6A24) — somatik	Xəstəlik şüuru yox.
Böyük depressiv pozuntu (TDP) — somatik fokuslu	Affektiv komponent dominant.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Uaytli İndeksi (14 maddə), SHAI.
- Tibbi yoxlama — bir dəfə tam, sonra təkrarlanmır.
- PHQ-9, ÜTP-7 komorbidlik.

8. Müalicə

1. KDT birinci sıra — koqnitiv yenidən strukturlaşdırma (fəlakətə salma), bədən yoxlama və təskinlik axtarışının qarşısının alınması (ekspozisiya +

ritualların qarşısının alınması), diqqət təlimi. Effekt: Cooper K. və b. Behav Res Ther 2017 meta-analiz.

2. SSGİ — orta–ağır halda və ya komorbid depressiya/ÜTP.
3. Tək həkim modeli (ing. single physician) — pasiyent yalnız bir ilkin tibbi yardım həkimi ilə işləyir; çoxsaylı yoxlamadan və «həkimdən həkimə gəzmə»dən qaçınma.
4. Təskinlik limit — həkim narahatlıq cavabında həddən artıq sübut vermir; qısa, ardıcıl mesaj.
5. Diqqətlilik (ing. mindfulness) əsaslı yanaşma köməkçi metod kimi tətbiq olunur.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Hipoxondriya üçün KDT — Salkovskis (Salkovskis P.), Varvik (Warwick H.) — Koqnitiv model — bədən sensasiyalarının «fəlakətli şərh edilməsi» mərkəzi yer tutur. Müdaxilə: psixoedukasiya, alternativ izahların araşdırılması, bədən yoxlama və təskinlik axtarışının davranış eksperimentləri, ekspozisiya. 12–16 seans.
2. Uaytli İndeksi (ing. Whiteley Index) — 14 maddəlik xəstəlik narahatlığı şkalası — qızıl standart skrininq.
3. Qısa Sağlamlıq Narahatlığı Sorğusu (SHAI — Short Health Anxiety Inventory) — Salkovskis P. — 18 maddə; klinik və əhali üzrə tədqiqatlarda istifadə olunur.
4. Tək Həkim Modeli (tək həkim prinsipi) pasiyent yalnız bir həkim ilə işləyir; bütün şikayətlər həmin həkim vasitəsilə idarə olunur; çoxsaylı yoxlama və ziddiyyətli rəylərin qarşısı alınır.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Cooper K. və b. Behav Res Ther 2017 meta-analiz — KDT əhəmiyyətli effekt; orta effekt ölçüsü.
- Greeven A. və b. Am J Psychiatry 2007 RKİ (randomizə edilmiş klinik sınaq) — KDT və paroksetin hər ikisi plasebodan üstün.

9. Proqnoz

- KDT və ya SSGİ ilə əksər pasiyentdə əhəmiyyətli yaxşılaşma müşahidə olunur.
- Müalicə olmadıqda xronikləşmə baş verir; tibbi resurslardan davamlı istifadə müşahidə olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pasiyent „uydurma“ xəstəlik göstərir, oyun oynayır»

Sübut: hipoxondriya klinik psixiatrik pozuntudur; pasiyentin narahatlığı həqiqidir; «oyun» və ya simulyasiya deyil. Faktisial pozuntusundan (6D50) fərqlənir.

Mif 2: «Tibbi yoxlama nə qədər çox aparılsa, pasiyent o qədər rahatlaşar»

Sübut: təkrar yoxlama qısamüddətli rahatlıq verir, sonra narahatlıq qayıdır; «yoxlama asılılığı» inkişaf edir. Tək həkim modeli və yoxlama məhdudlaşdırılması tövsiyə edilir.

Mif 3: «Təskinlik („sən sağlamsan“) müalicə vasitəsidir»

Sübut: təkrar təskinlik pozuntunu gücləndirir — pasiyent sübut axtarmağa davam edir. Strukturlaşdırılmış həkim cavabı: bir dəfəlik qiymətləndirmə, sonra qısa standart mesaj.

Mif 4: «internet axtarışı pasiyentin özünü məlumatlandırmasına kömək edir»

Sübut: «kiberxondriya» (ing. cyberchondria) — internet axtarışı narahatlığı gücləndirir, fəlakətləşdirməni artırır; məhdudlaşdırma və ya strukturlaşdırma tövsiyə edilir.

Mif 5: «Hipoxondriya yalnız yaşlı pasiyentlərdə baş verir»

Sübut: başlanğıc erkən-orta yetkinlik dövrünə təsadüf edir; yaş aralığı genişdir.

Mif 6: «Yalnız antidepresant effektivdir, terapiya köməksizdir»

Sübut: Greeven 2007 — KDT və paroksetin hər ikisi placebodan üstün; KDT birinci sıra (uzunmüddətli effekt SSGİ ilə müqayisədə).

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B23 Hipoxondriya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Kuper K. və b. Sağlamlıq təşvişi üçün koqnitiv davranış terapiyası: sistematik icmal və meta-analiz. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 2017;90:8–20.

4. Qriven A. və b. Hipoxondriyanın müalicəsində koqnitiv davranış terapiyası və paroksetin: randomizə edilmiş nəzarətli sınaq. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2007;164(1):91–99.
5. Salkovskis P.M., Rimes K.A., Uorvik H.M. Sağlamlıq Təşvişi İnventarı: sağlamlıq təşvişinin və hipoxondriyanın ölçülməsi üçün şkalaların hazırlanması və etibarlılıq yoxlanışı. «Psixoloji Tibb» (Psychol Med). 2002;32(5):843–853.
6. Bleyçhardt Q., Hiller V. Alman əhalisində hipoxondriya və sağlamlıq təşvişi. «Britaniya Sağlamlıq Psixologiyası Jurnalı» (Br J Health Psychol). 2007;12(Hissə 4):511–523.

XBT-11 **6B24**	**6B24 YIĞMA POZUNTUSU** **Hoarding disorder**
XBT-10 F63.8	Digər vərdiş və impuls pozuntuları
DSM-5-TR F42.3	Yığıcılıq pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Yığma pozuntusu (XBT-11: 6B24; DSM-5-TR: 300.3; ing. hoarding disorder) — əşyaları əldə etmək və ya saxlamaq tələbatı və onları atmaqdan davamlı çətinlik, bu da yaşayış sahəsinin (otaqların funksional məqsədli istifadə edilə bilməyəcək dərəcədə) tıxanmasına gətirib çıxarır. OKP spektri kateqoriyasına aid edilir.

2. Tarixçə

- Frost R.O., Hartl T.L. (1996) — yığma pozuntusunun koqnitiv-davranış modeli.
- DSM-IV-də OKP-nin alt-tipi kimi qeyd edilirdi.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 — ayrı diaqnostik kateqoriya kimi rəsmiləşdirilib (sübut bazası — fərqli klinik təzahürlər, gediş, müalicəyə cavab).

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 2–6% (Samuels J.F. və b. Behav Res Ther 2008).
- Yaşlılarda yayılma daha yüksək (təxminən 6%).

- Cins: təxminən bərabər; klinik nümunələrdə qadınlar üstünlük təşkil edir.
- Başlanğıc: yeniyetməlik (orta hesabla 11–15 yaş); şiddət yaşla artır.
- Komorbidlik: TDP təxminən 50%, OKP təxminən 20%, ÜTP, sosial narahatlıq, DDHP.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 50% təşkil edir.
- Neyrobioloji — frontostriatal dövrə pozulması; OKP-dən fərqli aktivasiya modelləri (Tolin D.F. və b. icmalları).
- Koqnitiv çatışmazlıq — kateqoriyalaşdırma, qərar qəbulu, diqqət (Frost və Hartl modeli).
- Əşyalara emosional bağlanma; itki travması.
- Yaşlılarda — koqnitiv enmə tətikləyicisi.

5. Klinik təzahürlər

- Əşyaların əldə edilməsi (alış, ödənişsiz əldə etmə, bağışlama) və ya saxlanması ilə bağlı davamlı çətinlik müşahidə olunur.
- Əşyaları atmaq və ya buraxmaq fikri əhəmiyyətli əzab-əziyyət yaradır.
- Çoxlu əşya yığılmaq və yaşayış sahəsini tutmaq — otaqlar funksional məqsədli istifadə edilə bilməz (yataq otağı yatmaq üçün, mətbəx yemək bişirmək üçün və s.).
- Bəzən «heyvan toplama» (ing. animal hoarding) — heyvanların kütləvi saxlanması.
- Xəstəliyin dərk edilməsi (ing. insight) çox vaxt zəifdir — pasiyent problemi qəbul etmir.
- Sağlamlıq və təhlükəsizlik risklərinə yanğın, infeksiyalar, yıxılma, sosial təcrid və evdən kənarlaşdırılma daxildir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Əldə edilən əşyaları atmaq və ya buraxmaqda davamlı çətinlik, dəyərindən asılı olmayaraq.

B. Bu çətinlik əşyaları saxlamağa davamlı tələbat və atmaqla bağlı distresdən qaynaqlanır.

C. Yığılma yaşayış sahəsini tıxayır və otaqların məqsədli istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə pozur.

D. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma (özünə, ailəyə, başqaları üçün təhlükəli mühit daxil olmaqla).

E. Tibbi vəziyyət (beyin zədəsi, demensiya) istisnası.

F. Başqa psixi pozuntu (OKP «obsessiyaları», TDP «enerji yoxluğu», psixotik pozuntu sayıqlamaları, autizm «məhdud maraqlar») ilə daha yaxşı izah olunmur.

Kvalifikator: excessive acquisition ilə; xəstəlik şüuru (yaxşı / orta — zəif / yox).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — ayrı kateqoriya; xəstəlik şüuru kvalifikatoru.
- «Heyvan toplama» (ing. animal hoarding) ayrı spesifikator olmasa da klinik cəhətdən tanınmış variantdır; baytar və ictimai sağlamlıq orqanları ilə əməkdaşlıq tələb olunur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Ev ziyarəti və ya foto sübutu — yaşayış sahəsinin vəziyyəti (Dağınıqlıq Şəkil Reytinqi; ing. Clutter Image Rating — CIR).
3. Şkala — Toplama Sorğusu-Yenilənmiş (ing. Saving Inventory-Revised, SI-R).
4. Komorbidlik və koqnitiv qiymətləndirmə (yaşlılarda demensiya istisnası — MMSE/MoCA).
5. Təhlükəsizlik və sağlamlıq riskinin qiymətləndirilməsi.

6.4 Differensial diaqnostika (cədvəl 6.4.1)

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
OKP (6B20)	Klassik obsessiyalar (təmizlik, simmetriya); yığma zamanı əşyalar emosional dəyər daşıyır.
TDP (6A70/6A71)	«Enerji yoxluğu» səbəbi ilə təmizləməmək; aktiv əşya əldə etmə yoxdur.
Demensiya	Koqnitiv enmə dominantdır; sonradan inkişaf etmiş toplama.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Autizm spektri (6A02)	Məhdud maraqlar və əşyalara bağlılıq; sosial-kommunikativ çatışmazlıq də mövcuddur.
Şizofreniya / sayıqlama	Sayıqlama məzmunu (təhlükə, məna).
Diogenes sindromu (yaşlılarda)	Özünə qulluq pozulması və toplama; sosial təcrid; demensiya komorbidliyi sıx olur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- SI-R (Toplama Sorğusu-Yenilənmiş), CIR (Dağınıqlıq Şəkil Reytinqi).
- Tibbi və koqnitiv müayinə (MMSE/MoCA yaşlılarda).
- Təhlükəsizlik qiymətləndirməsi.

8. Müalicə

1. KDT toplama üçün (Frost R.O., Tolin D.F., Steketee G.) — birinci sıra; təlimatlaşdırılmış 26 seanslı protokol — motivasiya artırma, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, qərarvermə təlimi, çeşidləmə və atma məşqləri, ev ziyarətləri. Sübut: Tolin D.F. və b. Depress Anxiety 2015 meta-analiz (12 seçmə, n=232) — simptomlar əhəmiyyətli azalır, lakin pasiyentlərin yarıdan çoxunda müalicədən sonra da çətinlik qalır.
2. SSGİ — sübut bazası məhduddur; OKP-də effektiv olan SSGİ toplamada daha zəif cavab verir. Adjunkt rolda.
3. Koqnitiv korreksiya (ing. cognitive remediation) — diqqət, kateqoriyalaşdırma, qərarvermə təlimi.
4. «Üzdə saxlama» (ing. buoyancy) yanaşması — pasiyentin daxili motivasiyasının dəstəklənməsi; məcburi təmizləmə ilə təkrar tıxanma riski.
5. İcma müdaxiləsi ictimai sağlamlıq, sosial xidmət və yanğın təhlükəsizliyi sahələrini əhatə edir.
6. Yaşlılarda — demensiya skrininqi və komorbid müdaxilə.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Yığma pozuntusu üçün KDT (Hoarding) — Stekiti (Steketee G.), Frost (Frost R.O.) təlimatlaşdırılmış 26 seans — motivasiya müsahibəsi, qərarvermə təlimi, sortlama məşqi, ev ziyarətləri, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma. IOCDF.

2. Yığma Sorğusu-Yenilənmiş (SI-R — ing. Saving Inventory-Revised) — Frost (Frost R.O.) — 23 maddə; üç alt-şkala (əldə etmə, atma çətinliyi, dağınıqlıq).
3. Dağınıqlıq Şəkil Reytinqi (ing. CIR — Clutter Image Rating) — 9 ballıq şkala; otağın tıxanma dərəcəsinin foto əsasında qiymətləndirilməsi.
4. Qrup KDT — iqtisadi cəhətdən səmərəli format; uzunmüddətli dəstək.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Tolin D.F. və b. RKİ-lər — KDT effektivdir; SSGİ məhdud.
- Saxena S. icmalları — SSGİ-yə cavab OKP-də müşahidə olunandan zəifdir.

9. Proqnoz

- Xronik gediş müşahidə olunur, şiddət yaşla artır.
- KDT ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma, lakin tam remissiya nadir.
- Komorbid demensiya proqnozu pisləşdirir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Toplama — sadəcə „kolleksiyaçı“ şəxsiyyət xüsusiyyəti və ya tənbəllik»

Sübut: toplama klinik pozuntudur — Frost və Hartl koqnitiv-davranış modeli; ayrı neyrobioloji model; funksional pozulma və sağlamlıq riski. Kolleksiyaçılıqdan fərqli olaraq əşyalar sistemləşdirilməmişdir və yaşayış sahəsini tıxayır.

Mif 2: «Pasiyentin evini güclə təmizləmək problemə son qoyar»

Sübut: məcburi təmizləmə pasiyentin razılığı olmadan — kütləvi əzab-əziyyət, travma və 12 ay ərzində tıxanmanın təkrar yaranması ilə nəticələnir. Pasiyent iştirakı ilə tədricən sortlama tövsiyə edilir.

Mif 3: «Toplama adi OKP-nin alt-tipidir, SSGİ kifayətdir»

Sübut: DSM-5 və XBT-11 ayrı kateqoriya; SSGİ-yə cavab OKP-dən zəifdir; KDT təlimatlaşdırılmış protokolla birinci sıra müalicə üsulu kimi tətbiq olunur.

Mif 4: «Heyvanları „kömək niyyəti ilə“ çox saxlamaq heyvanlar üçün yaxşıdır»

Sübut: «animal toplama» — heyvanların gigiyena, qida və tibbi qulluqla zəif təmin olunması ilə nəticələnir; çoxlu heyvan ölümü, sağ qalanların ağır vəziyyətdə olması; veteriner və ictimai sağlamlıq orqanları müdaxiləsi tələb olunur.

Mif 5: «Yaşlılarda toplama „normal yaşlanma“dır»

Sübut: yaşlılarda toplama demensiya göstəricisi ola bilər (xüsusilə frontotemporal); koqnitiv qiymətləndirmə tələb olunur.

Mif 6: «Bir dəfə təmizləyəndən sonra problem həll olunur»

Sübut: toplama xronik pozuntudur; uzunmüddətli müalicə və icma dəstəyi tələb olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B24 Yığım pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Frost R.O., Hartl T.L. Kompulsiv yığım davranışının koqnitiv-davranışçı modeli. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1996;34(4):341–350.
4. Steketee Q., Frost R.O. Yığım pozuntusunun müalicəsi: Terapevt üçün təlimat. Oksford Universiteti Nəşriyyatı; 2014.
5. Tolin D.F., Frost R.O., Steketee Q. və b. Yığım pozuntusu üçün koqnitiv-davranışçı terapiya: meta-analiz. «Depressiya və Təşviş» (Depress Anxiety). 2015;32(3):158–166.
6. Samuels C.F. və b. İcma əsaslı nümunədə yığım davranışının yayılması və əlaqəli amilləri. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 2008;46(7):836–844.
7. Saksena S. Kompulsiv yığımın farmakoterapiyası. «Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Clin Psychol). 2011;67(5):477–484.

XBT-11 **6B25**	**6B25 BƏDƏNƏ YÖNƏLMİŞ TƏKRAR DAVRANIŞLAR POZUNTUSU** **Body-focused repetitive behaviour disorders**
XBT-10 F63.3	Trixotillomaniya

XBT-11 **6B25**	**6B25 BƏDƏNƏ YÖNƏLMİŞ TƏKRAR DAVRANIŞLAR POZUNTUSU** **Body-focused repetitive behaviour disorders**
DSM-5-TR F63.3 / F42.4	Trixotillomaniya (saç çəkmə pozuntusu)

1. Tərif və nozologiya

Bədənə yönəlmiş təkrar davranış pozuntuları (XBT-11: 6B25 Body-focused Repetitive Behaviour Disorders) — pasiyentin öz bədəninə (saç, dəri, dırnaq) təkrarlanan müdaxiləsi ilə xarakterizə olunan pozuntu qrupudur. Əsas alt-tiplər:

- 6B25.0 — Trikotillomaniya (saç çəkmə pozuntusu);
- 6B25.1 — Ekskoriyasiya / Dermatillomaniya (dəri qaşıma pozuntusu);
- 6B25.Y — Digər müəyyən edilmiş (dırnaq dişləmə — onikofaqiya, dodaq dişləmə, yanaq dişləmə).

DSM-5-TR-də Trikotilomania (F63.3) və Eksoreasiya (L98.1) ayrı kodlanır, lakin OKP spektri kateqoriyasına aid edilir.

2. Tarixçə

- Hallopeau F.H. (1889) — «trikotillomaniya» termini (ing. trichotillomania).
- DSM-III-R (1987) — Trikotillomaniya impuls nəzarəti pozuntusu kimi.
- DSM-5 (2013) — OKP spektri kateqoriyasına keçirilmiş; ekskoriyasiya ayrı diaqnoz kimi əlavə edilmişdir.
- XBT-11 (2019) — birgə kateqoriya kimi (6B25 ümumi başlığı).

3. Epidemiologiya

- Trikotilomania ömürlük yayılma: 0,5–2%; klinik formada qadınlarda 4:1 nisbətində müşahidə olunur.
- Eksoreasiya: 1,4–5,4%; qadınlarda daha yüksəkdir.
- Başlanğıc: yeniyetməlik (10–13 yaş).

- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, OKP, BDP, DDHP.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 30–40%; ailə tarixçəsi yayğın.
- Genetik — SAPAP3 (SLITRK1) — siçanlarda hiperqruiminq (ing. hypergrooming) fenotipi.
- Neyrobioloji — OKP-yə bənzər kortiko-striato-talamo-kortikal dizrequlyasiya, lakin fərqli profil.
- Davranış mexanizmləri: stres reaksiyası, «avtomatik» (ing. automatic) və «diqqət yönəldilmiş» (ing. focused) alt-tiplər alt-tiplər.

5. Klinik təzahürlər

Trikotilomania (6B25.0)

- Saç çəkmə — adətən başdan, qaşlardan, kirpiklərdən; bəzən bədənin başqa hissələrindən.
- Saçın gözlə görünən itkisi müşahidə olunur.
- «Çəkmədən əvvəl gərginlik» (ing. pre-pulling tension) və ya «çəkmədən sonra rahatlıq» (ing. post-pulling relief) — bütün pasiyentlərdə olmaya bilər.
- Trikofagiya (çəkdiyi saçın yeyilməsi) — 10–20% pasiyentdə; «trikobezoar» — mədə-bağırsaq tıxanması cərrahi müdaxilə tələb edə bilər.

Eksoreasiya / Dermatilomania (6B25.1)

- Dərinin qoparılması və qaşıması — üz, qol, dərinin dəyişmiş sahələri (sızanaq, həşərat sancması yeri).
- Yaralanma, qabıq, izlər.
- İnfeksiya, yara izi, kosmetik nəticələr.

Ümumi xüsusiyyətlər

- Pasiyent davranışı dayandırmağa təkrar uğursuz cəhdlər göstərir.
- Utancdan sosial təcrid (parik istifadəsi, ağzı/qolu örtmək).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Saç çəkmə (trikotilomaniyada) və ya dəri qaşıma (ekskoriyasiyada) — gözlə görünən saç itkisi və ya dəri zədəsi.

B. Pasiyent davranışı dayandırmaq və ya azaltmaq üçün təkrar cəhdlər göstərir.

C. Davranış əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma yaradır.

D. Tibbi vəziyyət (alopecia areata, dermatoloji xəstəlik) və ya başqa psixi pozuntu (BDP-də görünüş motivli; psixoz sayıqlamada; maddə induksiyalı) istisnası.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — Trikotilomania (F63.3) və Ekskoriyasiya (L98.1) ayrı kodlanır.
- XBT-11 — XBT-11-də hər iki pozuntu birgə 6B25 ümumi başlığı altında birləşdirilir; alt-spesifikatorlar mövcuddur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (pasiyent çox vaxt utancdan açıq danışmır).
2. Dermatoloji müayinə — saç itkisi və dəri zədəsinin başqa səbəblərinin istisnası (alopesiya areata, tinea kapitis, ekzema).
3. Şkala — Massaçusets Ümumi Xəstəxanası Saçyolma Şkalası (MGH-HPS), Dəri Qaşıma Şkalası (ing. Skin Picking Scale)
4. Komorbidliyin skrininqi aparılır.
5. Mədə-bağırsaq simptomları olduqda trikofagiya skrininqi aparılır.

6.4 Differensial diaqnostika (cədvəl 6.4.2)

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Alopecia areata	Autoimmün; sərhədləri dəqiqdir, «exclamation mark hairs»; saç çəkmə davranışı yoxdur.
Tinea capitis	Göbələk infeksiyası; KOH (kalium hidroksid) müayinəsi aparılır.
BDP (6B21)	Görünüş əsaslı obsessiya; dəri qaşıma kosmetik məqsədli.
OKP (6B20)	Çoxsaylı obsessiyalar; saç və dəri davranışı dominant deyil.
Stereotipik hərəkət pozuntusu (6A06)	Ritmik təkrarlanan motor; bədənə spesifik müdaxilə yox.
Faktisial pozuntu (6D50)	Tibbi sübut axtarmaq motivasiyası.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Psixotik sayıqlama (parazit hissi — Ekbom)	Sayıqlama məzmunu.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- MGH-HPS (trikotillomaniya), Dəri Qaşıma Şkalası-Yenilənmiş (ing. Skin Picking Scale-Revised)
- Dermatoloji müayinə.
- Trikofagiya halında mədə-bağırsaq ultrasəs müayinəsi aparılır.

8. Müalicə

1. Vərdiş Əvəzləmə Təlimi (ing. Habit Reversal Training, HRT) birinci sıra müalicə üsuludur — şüurlanma təlimi, rəqib reaksiya (məs. yumruğu sıxma), motivasiya, sosial dəstək. Sübut: Bloch M.H. və b. Biol Psychiatry 2007 meta-analiz.
2. Qəbul və Öhdəlik Terapiyası (ing. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) emosional komponentə yönəlir.
3. Comprehensive Behavioral Treatment (ComB, Mansueto) — HRT və çoxkomponentli davranış müdaxiləsi.
4. N-asetilsistein (NAC) — sübut bazası inkişaf etməkdə; Grant J.E. və b. Arch Gen Psychiatry 2009 RKİ — trikotilomaniyada effektivlik.
5. SSGİ — sübut bazası məhduddur; OKP-də effektiv olan SSGİ trikotillomaniyada zəif cavab verir; klomipramin nisbətən üstündür.
6. Refrakter hallarda atipik antipsixotiklər köməkçi terapiya kimi tətbiq olunur.
7. Dermatoloji qulluq — yaralanma və infeksiyaların müalicəsi.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Vərdiş Əvəzləmə Təlimi (ing. Habit Reversal Training, HRT) — Azrin (Azrin N.H.), Nunn (Nunn R.G.) beş əsas komponent — şüurlanma təlimi, rəqib reaksiya, motivasiya, sosial dəstək, ümumiləşdirmə. Bədənə yönəlmiş təkrar davranış pozuntularında ən etibarlı üsul hesab edilir.
2. Kompleks Davranış Müalicəsi (ing. ComB — Comprehensive Behavioral Treatment) — Mansueto (Mansueto C.S.) — SCAMP modeli — sensor, koqnitiv, affektiv, motor və mühit modallıqlarına görə fərdiləşdirilmiş yanaşma.

3. Qəbul və Öhdəlik Terapiyası (ing. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) — emosional komponentə diqqət yetirilir; Woods D.W. və b. Behav Res Ther 2006 RKİ.
4. NAC — N-asetilsistein — Qlutamaterjik modulator; 1200–2400 mq/gün; Grant J.E. Arch Gen Psychiatry 2009.
5. Massaçusets Ümumi Xəstəxanası Saçyolma Şkalası (ing. Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale, MGH-HPS) 7 maddə; tezlik və intensivliyi qiymətləndirir.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Bloch M.H. Biol Psychiatry 2007 meta-analiz — HRT trikotillomaniya üçün ən çox sübuta malik üsuldur.
- Grant J.E. Arch Gen Psychiatry 2009 — NAC 1200–2400 mq/gün dozada effektivliyi təsdiqlənmişdir.

9. Proqnoz

- Xronik, dalğalı gediş (ing. «waxing and waning») xarakterikdir.
- HRT ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma; komorbidliyin müalicəsi vacibdir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Saç çəkmə və dəri qaşıma „pis vərdiş“dir, ciddi pozuntu deyil»

Sübut: klinik pozuntudur; funksional pozulma, sosial təcrid, infeksiya və cərrahi müdaxilə tələb edən trikobezoar riskləri mövcuddur.

Mif 2: «Pasiyent iradi olaraq dayandıra bilər»

Sübut: pasiyent dəfələrlə cəhd edir və uğursuz olur — bu pozuntunun əsas əlamətidir; HRT və ya farmakoterapiya tələb olunur.

Mif 3: «SSGİ trikotilomaniya üçün effektivdir (OKP kimi)»

Sübut: SSGİ-yə cavab OKP-dən zəifdir; HRT birinci sıra; NAC köməkçi terapiya kimi; klomipramin SSGİ-dən nisbətən üstündür.

Mif 4: «Saçın gizlədilməsi (parik, makiyaj) həll yoludur»

Sübut: kosmetik gizlətmə qısamüddətli təsir göstərir; əsas davranışa müdaxilə tələb olunur.

Mif 5: «Yalnız hipnoz və ya psixoanalitik dərin terapiya əsas davranış səbəbini həll edər»

Sübut: sübut bazası məhduddur; HRT əsaslı davranış yanaşmaları üstündür.

Mif 6: «Dəri qaşıma „akne“ və ya kosmetik problemə cavabdır»

Sübut: klinik pozuntu — pasiyent davranışın qarşısını ala bilmir, dəridə yara izi və infeksiya yaradır; klinik müdaxilə tələb olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «XBT-11». 6B25 Bədənə yönəlmiş təkrarlanan davranış pozuntuları. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «DSM-5-TR». 2022.
3. Blox M.H. və b. Sistematik icmal: trikotillomaniyanın farmakoloji və davranışçı müalicəsi. «Bioloji Psixiatriya» (Biol Psychiatry). 2007;62(8):839–846.
4. Qrant C.E. və b. N-asetilsistein, qlutamat modulatoru, trikotillomaniyanın müalicəsində: ikiqat kor, plasebo nəzarətli tədqiqat. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2009;66(7):756–763.
5. Vuds D.V., Vetternek K.T., Flessner K.A. Trikotillomaniya üçün qəbul və öhdəlik terapiyası ilə vərdişin dəyişdirilməsinin birləşməsinin nəzarətli qiymətləndirilməsi. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 2006;44(5):639–656.
6. Mansueto K.S., Qoldfinqer Qolomb R., Tomas A.M., Stemberger R.M.T. Trikotillomaniyanın davranışçı müalicəsi üçün kompleks model. «Koqnitiv və Davranışçı Təcrübə» (Cogn Behav Pract). 1999;6(1):23–43.
7. Azrin N.H., Nann R.Q. Vərdişin dəyişdirilməsi: əsəbi vərdişlərin və tiklerin aradan qaldırılması üsulu. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 1973;11(4):619–628.

6B40–6B4Z STRES İLƏ ƏLAQƏLİ POZUNTULAR

Streslə xüsusi əlaqəli pozuntular (ing. disorders specifically associated with stress)

XBT-11 **6B40**	**6B40 POSTTRAVMATİK STRESS POZUNTUSU (PTSP)** **Post traumatic stress disorder**
XBT-10 F43.1	Posttravmatik stress pozuntusu
DSM-5-TR F43.10	Posttravmatik stress pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Posttravmatik Stress Pozuntusu (PTSP; XBT-11: 6B40; DSM-5-TR: 309.81) — ölüm və ya ölüm təhlükəsi, ciddi yaralanma və ya cinsi zorakılığa fərdi məruz qalma və ya bilavasitə şahidi olduqdan sonra inkişaf edən, üç əsas simptom sahə ilə xarakterizə olunan pozuntudur: yenidən təcrübə (intruzivlər), qaçınma, davamlı təhlükə hissi (XBT-11) / koqnitiv-əhval dəyişikliklər və hiperoyanıqlıq

2. Tarixçə

- «Qumbara şoku» (ing. shell shock; Birinci Dünya müharibəsi), «döyüş yorğunluğu» (ing. combat fatigue) (İkinci Dünya).
- DSM-III (1980) — «Posttravmatik Stres Pozuntusu» (ing. posttraumatic stress disorder) — Vyetnam müharibəsi veteranları üzrə tədqiqatlar əsasında.
- DSM-5 (2013) — təşviş pozuntularından ayrılaraq «Travma və stresorla əlaqəli pozuntular» (ing. trauma- and stressor-related disorders) kateqoriyasına keçirilmişdir; A meyarı daralmışdır (yalnız konkret travma növləri).
- XBT-11 (2019) — daha kompakt diaqnostik konsepsiya; kompleks PTSP (6B41) ayrı kateqoriya kimi rəsmiləşdirilib.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 3,9% (ing. WHO World Mental Health), ABŞ-da təxminən 6,8%.
- Cins: qadınlarda 2 dəfə yüksək (cinsi zorakılığa məruz qalma riskinə görə).
- Travma növünə görə risk: cinsi zorakılıq təxminən 50% PTSP, fiziki hücum təxminən 25%, qəza təxminən 10%, təbii fəlakət təxminən 5%.
- Komorbidlik: TDP təxminən 50%, ÜTP, panik, maddə istifadəsi, ŞPP, kompleks PTSP.
- İntihar (suisid) riski əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 30–40% təşkil edir.
- Neyrobioloji — amigdala hiperreaktivliyi, prefrontal-amigdala tənzimləməsinin pozulması, hipokamp həcminin azalması, hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) oxunun dizrequlyasiyası (kortizol səviyyəsinin paradoksal şəkildə aşağı olması).
- Travma xüsusiyyətləri — şiddət, müddət, başqaları tərəfindən təşkil edilmiş zorakılıq (ing. intentional — qəsdən törədilmiş), uşaqlıq dövründə baş verməsi.
- Risk amilləri — əvvəlki travma, əvvəlki psixiatrik tarixçə, sosial dəstəyin olmaması, qadın cinsi, peritravmatik dissosiasiya.
- Qoruyucu — sosial dəstək, posttravmatik mənа axtarışı.

5. Klinik təzahürlər

Üç əsas sahə (XBT-11)

- Yenidən təcrübə — intruziv xatirələr, flashback, kabuslar; tətikləyicilərlə kəskin əzab-əziyyət və somatik reaksiyalar.
- Qaçınma — travma ilə bağlı düşüncələrdən, hisslərdən, xatırladıcılardan və vəziyyətlərdən yayınma.
- Davamlı təhlükə hissi (hiperoyanıqlıq) — hiperdiqqətlilik, asanlıqla diksinmə, yuxu pozulması, qıcıqlanma.

DSM-5-TR əlavə sahə — koqnitiv-əhval dəyişiklikləri

- Mənfi inanclar (özü, başqaları və dünya haqqında) formalaşır.
- Anhedoniya və sosial təcrid müşahidə olunur.

- Hisslərin keyləşməsi və davamlı mənfi əhval müşahidə olunur.

Müddət

Simptomlar ≥ 1 ay; başlanğıc travmadan sonra gecikə bilər (gecikmiş başlanğıc — travmadan 6 aydan çox sonra).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Travmatik hadisəyə məruz qalma (fərdi, şahid, yaxınların ölümü/zədəsi haqqında məlumat, peşə kontekstində travmatik məlumata təkrar məruzlanma).

B. Yenidən təcrübə (intruziv xatirələr, flashback, kabuslar).

C. Travma xatırladıcılarından qaçınma.

D. XBT-11: davamlı təhlükə hissi; DSM-5-TR: koqnitiv-əhval dəyişiklikləri və hiperoyanıqlıq.

E. Müddət ≥ 1 ay.

F. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

G. Maddə və ya tibbi vəziyyət istisnası.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR: 4 simptom sahə (intruzivlər, qaçınma, koqnitiv-əhval, hiperoyanıqlıq); dissosiativ alt tip kvalifikatoru (depersonalizasiya/derealizasiya); gecikmiş başlanğıc.
- XBT-11 (6B40): 3 simptom sahə (daha kompakt); kompleks PTSP ayrı kateqoriya (6B41).
- NICE NG116 (ing. 2018, Post-traumatic stress disorder): diaqnostika strukturlaşdırılmış müsahibə (CAPS-5).
- VA/DoD 2023: qızıl standart diaqnostika CAPS-5; birinci tibbi yardımda PCL-5 skrininq.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + travma tarixçəsi.
2. CAPS-5 (ing. Clinician-Administered PTSD Scale) — qızıl standart strukturlaşdırılmış müsahibə.
3. PCL-5 (ing. PTSD Checklist) — 20 maddədən ibarət özünüqiymətləndirmə skrininqidir.

4. Komorbidlik (TDP, ÜTP, maddə, ŞPP, kompleks PTSP).
5. Suicid riski (C-SSRS).
6. Tibbi və travmatik beyin zədəsi (TBZ) istisnası.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Kəskin stress reaksiyası (XBT-11: QE84; DSM-5-TR: kəskin stress pozuntusu, KSP)	3 gündən 1 aya qədər.
Kompleks PTSP (6B41)	Özünütəşkilin pozulması (affekt, mənlik, münasibətlər).
Uyğunlaşma pozuntusu (6B43)	Travma A meyarına uyğun gəlmir.
TDP (6A70/6A71)	Affektiv simptomlar; intruzivlər və qaçınma yoxdur.
Panik pozuntusu (6B01)	Atak gözlənilməyəndir.
ŞPP (6D10.x)	Davamlı şəxsiyyət pozuntusu modeli; impulsivlik və münasibət problemləri.
Dissosiativ pozuntular (6B6x)	Dissosiasiya üstünlük təşkil edir; PTSP-də dissosiativ alt-tip kvalifikator ola bilər.
Travmatik beyin zədəsi (TBZ)	Neyroloji tapıntılar; koqnitiv çatışmazlıq.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- CAPS-5 — qızıl standart.
- PCL-5 (20 maddə) — skrininq.
- PHQ-9, ÜTP-7, C-SSRS — komorbidlik.
- Travma tarixçəsi (LEC-5 — ing. Life Events Checklist).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (VA/DoD 2023, APA 2017, NICE NG116 konsensusu)

1. Birinci sıra: travmaya yönəlmiş psixoterapiya — fərdi qaydada:

- Uzadılmış ekspozisiya (ing. PE — Prolonged Exposure, Foa E.B.) — canlı (in vivo) və təsəvvürdə (imaqinal) ekspozisiya travmatik xatirəyə.
- Koqnitiv emal terapiyası (ing. Cognitive Processing Therapy, Resick P.A., CPT) — koqnitiv yenidən strukturlaşdırma; 12 seans.
- EMDR (ing. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Shapiro F.) — ikitərəfli stimullaşdırma və travmatik xatirənin emalı.
- Trauma-Focused KDT (TF-KDT, Cohen J.) — uşaq və yeniyetmələrdə.

2. Birinci sıra farmakoterapiya: SSGİ (sertralin və paroksetin — FDA təsdiqi PTSP üçün), SNGİ (venlafaksin).
3. İkinci sıra: mirtazapin, nefazodon (hepatotoksiklik riski səbəbindən ehtiyatla).
4. Kabuslar üçün — prazosin (α1-adrenoreseptor antaqonisti) — sübut bazası mübahisəlidir (Raskind 2003 müsbət, 2018-ci il PACT sınağı nəticəsiz olmuşdur); fərdi cavab.
5. Köməkçi terapiya kimi atipik antipsixotiklər (refrakter hallarda) tətbiq olunur; uzunmüddətli istifadə üçün benzodiazepinlər əks göstərişdir (PTSP gedişini pisləşdirir).
6. EKT — refrakter ağır komorbid depressiyada.
7. Müalicə müddəti — psixoterapiya 12–16 seans; farmakoterapiya remissiyadan sonra ≥ 12 ay.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Uzadılmış Ekspozisiya (ing. PE — Prolonged Exposure) Foa E.B. — travmatik xatirəyə imaginal ekspozisiya (təkrarlanan, ardıcıl təsvir) + in vivo ekspozisiya (qaçınılan situasiyalara). 10–15 seans. Sübut: Foa E.B. və b. RKİ-ləri; meta-analizlərdə qızıl standart effekt.
2. Koqnitiv Emal Terapiyası (ing. Cognitive Processing Therapy, CPT) — Resik (Resick P.A.) — Koqnitiv yenidən strukturlaşdırma — travma haqqında «stuck points» (təhlükəsizlik, etibar, güc və nəzarət, özünə qiymət, yaxınlıq). 12 seans. Resick P.A. və b. RKİ-ləri.
3. Göz Hərəkəti ilə Desensibilizasiya və Yenidən Emal (ing. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) — Şapiro (Shapiro F.) — ikitərəfli stimullaşdırma (göz hərəkətləri, səs və ya toxunma yolu ilə) ilə travmatik xatirənin yenidən emalı. 8 fazalı protokol. Sübut: Bisson J.I. və b. Cochrane 2013 — KDT-yə müqayisəli effekt.

4. Travmaya yönəlmiş koqnitiv-davranış terapiyası (TF-CBT) (ing. Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy, TF-CBT) — Koen (Cohen J.), Mannarino (Mannarino A.) — 3–18 yaşlı uşaq və yeniyetmələr üçün; PRACTICE protokolu (psixoedukasiya, relaksasiya, affektin modulyasiyası, koqnitiv öhdəsindən gəlmə, travma narrativi, canlı məşq, birgə seanslar, təhlükəsizliyin gücləndirilməsi).
5. həkim Tərəfindən Tətbiq edilən PTSP Şkalası (ing. Clinician-Administered PTSD Scale, CAPS-5) — 30 maddədən ibarət strukturlaşdırılmış müsahibədir.
6. PTSP Yoxlama Siyahısı (PCL-5 — PTSD Checklist) — 20 maddəlik özünüqiymətləndirmə; skrininq və izləmə.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- VA/DoD 2023 Klinik Təlimatı («Posttravmatik Stress Pozuntusu və Kəskin Stress Pozuntusunun İdarə Edilməsi»): travma-fokuslu psixoterapiya birinci sıra (güclü tövsiyə); farmakoterapiya birinci sıra alternativ; psixoterapiya + farmakoterapiya kombinasiyası adətən tövsiyə edilmir; benzodiazepin əks göstərişdir.
- APA 2017 PTSD Guideline: CPT, PE, koqnitiv terapiya və travma-fokuslu KDT — güclü tövsiyə; EMDR — şərti tövsiyə. VA/DoD 2023 və ISTSS 2018 EMDR-i CPT və PE ilə eyni yüksək səviyyəyə qoyur.
- NICE NG116 (2018): travma-fokuslu KDT və ya EMDR; SSGİ ikinci sıra.
- ISTSS 2018: beynəlxalq tövsiyələr.
- Kritik hadisə stress debriefinqi (ing. CISD — Critical Incident Stress Debriefing) — Cochrane (Rose S. və b. 2002) və NICE tövsiyə etmir; bəzi tədqiqatlarda PTSP riskini artırır.

9. Proqnoz

- Travma-fokuslu psixoterapiya ilə əksər pasiyentlərdə əhəmiyyətli yaxşılaşma müşahidə olunur.
- Erkən müdaxilə olmadıqda xronikləşmə baş verir.
- Komorbid TDP, maddə istifadəsi pis proqnoz göstəriciləridir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «PTSP yalnız müharibə veteranlarında olur»

Sübut: PTSP istənilən travmatik hadisədən sonra inkişaf edə bilər — cinsi zorakılıq (təxminən 50% inkişaf), fiziki hücum, qəzalar, təbii fəlakətlər, tibbi prosedurlar.

Veteranlarda rastgəlmə tezliyi yüksəkdir, lakin pozuntu ümumi əhali (populyasiya) arasında da geniş yayılmışdır.

Mif 2: «CISD (ing. Critical Incident Stress Debriefing) travmadan sonra PTSP-nin qarşısını alır»

Sübut: Cochrane (Rose S. və b. 2002) — CISD PTSP riskini azaltmır, bəzi tədqiqatlarda artırır. NICE və VA/DoD açıq tövsiyə etmir. Erkən müdaxilə kimi «ehtiyatlı gözləmə», yalnız simptomları olan pasiyentlərə isə travmaya yönəlmiş KDT tətbiq olunur.

Mif 3: «Pasiyent travma haqqında danışmamalıdır, „açmaq“ zərərlidir»

Sübut: sübuta əsaslanan travmaya yönəlmiş terapiya metodları (PE, CPT, EMDR) məhz travmatik xatirə ilə işləyir; uyğun strukturlaşdırılmış formada təsirlidir. Qaçınma PTSP-ni gücləndirir.

Mif 4: «Benzodiazepin PTSP üçün yaxşı müalicədir»

Sübut: VA/DoD 2023, APA, NICE — benzodiazepin əks-göstərişdir; PTSP gedişini pisləşdirir, koqnitiv emala mane olur, asılılıq potensialı yaradır.

Mif 5: «Travmatik xatirələri unutmaq əsas məqsəddir»

Sübut: məqsəd unutqanlıq deyil, xatirə ilə fəaliyyət göstərə bilmək — emosional reaksiya azalır, lakin xatirə qalır. Pasiyent travma haqqında danışa bilir əzab-əziyyət olmadan.

Mif 6: «Kanabis (kannabidiol, CBD) PTSP-ni tam sağaldır»

Sübut: VA/DoD — kannabis tövsiyə edilmir; ilkin tədqiqatlar var, lakin klinik tövsiyə üçün kifayət deyil; THC PTSP gedişini pisləşdirə bilər.

Mif 7: «MDMA-əsaslı terapiya rəsmi müalicədir»

Sübut: MDMA ilə dəstəklənən psixoterapiya tədqiqat mərhələsindədir; FDA 2024 təsdiq tələbi rədd edilib (yenidən araşdırma tələb olunur); standart klinik tətbiqdə deyil.

Mif 8: «EMDR sübutu zəifdir — yalnız plasebo effektidir»

Sübut: Bisson J.I. Cochrane 2013, VA/DoD 2023 və ISTSS 2018 — EMDR güclü tövsiyə, CPT və PE ilə müqayisəli effekt. APA 2017 istisnadır: orada EMDR şərti tövsiyədir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «XBT-11». 6B40 Posttravmatik stres pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «DSM-5-TR». 2022.
3. ABŞ Veteranlar İşləri Departamenti / Müdafiə Departamenti. Posttravmatik stres pozuntusunun və kəskin stres pozuntusunun idarə edilməsi üzrə klinik təcrübə təlimatı. 2023.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Posttravmatik stres pozuntusunun müalicəsi üzrə klinik təcrübə təlimatı. 2017.
5. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG116. Posttravmatik stres pozuntusu. 2018.
6. Bisson C.İ., Roberts N.P., Endrü M. və b. Yetkinlərdə xroniki posttravmatik stres pozuntusunun (PTSD) psixoloji müalicəsi. «Cochrane Sistemli İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2013;(12):CD003388.
7. Foa E.B., Xembri E.A., Rotbaum B.O. PTSD üçün uzadılmış ekspozisiya terapiyası. Oksford Universiteti Nəşriyyatı; 2007.
8. Resik P.A., Monson K.M., Çard K.M. PTSD üçün koqnitiv emal terapiyası: Kompleks təlimat. Guilford Press; 2017.
9. Rouz S., Bisson C., Çörçill R., Vesseli S. Posttravmatik stres pozuntusunun qarşısının alınması üçün psixoloji debriefinq. «Cochrane Sistemli İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2002;(2):CD000560.
10. Şapiro F. Göz hərəkətləri ilə desensibilizasiya və yenidən emal (EMDR) terapiyası: Əsas prinsiplər, protokollar və prosedurlar. 3-cü nəşr. Nyu York: Guilford Press, 2018.
11. Koen C.A., Mannarino A.P., Deblinger E. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə travmanın və travmatik kədərin müalicəsi. 2-ci nəşr. Nyu York: Guilford Press, 2017.
12. Raskind M.A., Peskind E.R., Çou B. və b. Hərbi veteranlarda posttravmatik stres pozuntusu üçün prazosinin sınağı. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2018;378(6):507–517.

	6B41 KOMPLEKS POSTTRAVMATİK STRESS POZUNTUSU (KPTSP)
XBT-11 **6B41**	**Complex post traumatic stress disorder**
XBT-10 F43.1	Posttravmatik stress pozuntusu
DSM-5-TR F43.10	Posttravmatik stress pozuntusu (DSM-5-TR-də ayrıca kateqoriya yoxdur)

1. Tərif və nozologiya

Kompleks Posttravmatik Stress Pozuntusu (KPTSP) (ing. XBT-11: 6B41 Complex Post-Traumatic Stress Disorder) — uzunmüddətli və ya təkrarlanan, qaçışın çətin və ya mümkünsüz olduğu travmaya (uzunmüddətli istismar, uşaqlıqda fiziki və ya cinsi zorakılıq, müharibə, işgəncə, insan ticarəti) cavab olaraq inkişaf edən pozuntudur. PTSP-nin üç simptom domeninə (yenidən təcrübə, qaçınma, davamlı təhlükə hissi) özünütəşkilin pozulması (ÖTP; ing. DSO — disturbances in self-organization) əlavə olunur: affektin tənzimlənmə pozulması, mənfi özünə qiymət, münasibətlərdə çətinlik.

XBT-11-də ilk dəfə rəsmi diaqnostik kateqoriya kimi əlavə edilmişdir; DSM-5-TR-də ayrıca KPTSP kateqoriyası yoxdur (PTSP-nin «dissosiativ xüsusiyyətlərlə» kvalifikatoru bəzi xüsusiyyətləri əhatə edir).

2. Tarixçə

- Herman J.L. (1992) — «Kompleks PTSP» konsepsiyası («Travma və Sağalma» kitabı); «həddindən artıq stress pozuntusu, başqa cür təsnif edilməyən» (DESNOS) — DSM-IV-ə daxil edilmədi.
- XBT-11 (2019) — rəsmi 6B41 kodu; PTSP-dən ayrılma sübut bazasına əsaslanır (Cloitre M. və b. icmalları).

3. Epidemiologiya

- Yayılma: birinci tibbi yardımda travmaya məruz qalmış pasiyentlər arasında 1–8% (Brewin C.R. və b. icmalları).

- Uşaqlıq istismarı tarixçəsi olan pasiyentlərdə xüsusilə yüksəkdir.
- Komorbidlik: TDP, ÜTP, dissosiativ pozuntular, ŞPP (klinik üst-üstə düşmə), maddə istifadəsi, yemə davranışı pozuntuları.

4. Etiologiya və patogenez

- Travma tipi — uzunmüddətli, təkrarlanan, başqaları tərəfindən təşkil edilmiş (şəxslərarası), qaçışın çətin olması.
- Uşaqlıqda baş verən travma — şəxsiyyət inkişafına geniş təsir.
- Neyrobioloji — PTSP ilə oxşar, lakin daha aydın ifadə olunmuş HPA disrequlyasiyası, dissosiasiya, affekt tənzimləmə pozulması.

5. Klinik təzahürlər

PTSP üç əsas sahə

- Yenidən təcrübə (intruzivlər).
- Qaçınma.
- Davamlı təhlükə hissi.

Özünütəşkilin pozulması (DSO — disturbances in self-organization) — KPTSP-nin əsas əlavəsi

- Affekt tənzimləmə pozulması — emosional dəyişkənlik, intensiv reaksiyalar, emosional keyləşmə.
- Mənfi özünə qiymət — davamlı utanc, günah, dəyərsizlik hissi.
- Münasibətlərdə çətinlik — yaxın münasibətlərdən qaçınma, davamlı şəkildə pozulmuş bağlanma.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (XBT-11)

A. Uzunmüddətli və ya təkrarlanan travmaya məruz qalma.

B. PTSP üç əsas sahə mövcuddur.

C. Özünütəşkilin pozulmasının (DSO) üç sahə:

1. Affekt tənzimləmə pozulması;
2. Mənfi özünə qiymət;
3. Münasibətlərdə çətinlik.

D. Əhəmiyyətli funksional pozulma.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 — ayrı kateqoriya; ÖTP əlavə meyar tələb edir.
- DSM-5-TR — KPTSP ayrı kateqoriya kimi yoxdur.; PTSP «dissosiativ xüsusiyyətlərlə» kvalifikatoru bəzi xüsusiyyətləri əhatə edir.
- ISTSS 2019 Complex PTSD Guidelines — fazalı yanaşma tövsiyə edir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + travma tarixçəsi (uzunmüddətli, təkrarlanan).
2. ITQ (ing. International Trauma Questionnaire — Cloitre M.) — PTSP və KPTSP fərqləndirilməsi üçün dizayn edilmiş.
3. Komorbidlik (xüsusilə ŞPP, dissosiativ pozuntular).
4. İntihar və özünə zərər riskinin qiymətləndirilməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
PTSP (6B40)	DSO komponenti yox.
ŞPP (6D10.x)	Klinik üst-üstə düşmə əhəmiyyətli; ŞPP-də impulsivlik, şəxsiyyətin identikliyinin pozulması və xronik İntihar davranışı üstünlük təşkil edir; KPTSP-də travma əsasında inkişaf etmiş simptomlar.
Dissosiativ pozuntular (6B6x)	Dissosiasiya dominant.
TDP (6A70/6A71)	Affektiv simptomlar; travma və DSO yox.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- ITQ (ing. International Trauma Questionnaire) — etibarlılığı yoxlanılmış qiymətləndirmə vasitəsidir.
- PCL-5 və ÖTP üzrə əlavə şkalalar tətbiq olunur.
- ŞPP skrininq (ing. McLean Screening Instrument for ŞPP).
- Suicid və özünə zərər (C-SSRS).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (ISTSS 2019)

1. Fazalı yanaşma (phase-based):
    - Faza 1 — stabilizasiya: təhlükəsizlik, emosional tənzimləmə bacarıqları, başa çıxma strategiyaları, psixoedukasiya.
    - Faza 2 — travmatik xatirələrin emalı: PTSP üçün sübutlu metodlar (PE, CPT, EMDR), lakin daha uzunmüddətli və ardıcıl.
    - Faza 3 — reinteqrasiya: münasibətlərin bərpası, həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması.
2. Skills Training in Affective and Şəxslərarası Regulation (STAIR — Cloitre M.) — travmatik xatirələrin emalından əvvəlki faza 1 müdaxiləsi.
3. Travma-fokuslu KDT və EMDR — uyğunlaşdırılmış formada.
4. DBT-PTSD (Bohus M.) — ŞPP komorbid hallarda.
5. SSGİ köməkçi terapiya kimi komorbid depressiya və narahatlıq olduqda tətbiq olunur.
6. Müalicə müddəti uzun (1–2 il və ya daha çox).
7. həkimin davamlılığı və terapevtik münasibət xüsusilə vacibdir.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Affektiv və Şəxslərarası Tənzimləmədə Bacarıq Təlimi (ing. Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation, STAIR) — Kluatr (Cloitre M.) — Faza 1 — emosional tənzimləmə və şəxslərarası bacarıqların inkişafı; sonra Narrativ hekayə danışma (ing. NST — Narrative Story Telling) ilə travmatik xatirələrin emalı. 16–24 seans.
2. Dialektik Davranış Terapiyası — PTSP (DBT-PTSD) — Bohus (Bohus M.), Linehan (Linehan M.) — DBT prinsipləri + travma-fokuslu komponentlər; xüsusilə ŞPP komorbid hallarda.
3. Narrativ Ekspozisiya Terapiyası (ing. Narrative Exposure Therapy, NET) — Şauer (Schauer M.), Noyner (Neuner F.), Elbert (Elbert T.) — Pasiyent həyat tarixçəsini ardıcıl danışır, travmatik epizodlar emal olunur; qaçqın və işgəncə qurbanlarında təsirlilik.
4. EMDR, CPT və PE uyğunlaşdırılmış formada, daha uzun və fazalı yanaşma daxilində tətbiq olunur.
5. Beynəlxalq Travma Sorğusu (ing. International Trauma Questionnaire, ITQ) — Kluatr (Cloitre M.) — PTSP və KPTSP fərqləndirilməsi üçün xüsusi olaraq etibarlılığı yoxlanılmış vasitədir.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- ISTSS 2019 Complex PTSD Guidelines — fazalı yanaşma.
- Cloitre M. və b. icmalları — STAIR + Narrativ ekspozisiya terapiyası (ing. Narrative Exposure Therapy) effektiv.
- Bohus M. DBT-PTSD — Randomizə edilmiş klinik sınaqların (RKİ) sübut bazası inkişaf etməkdədir.

9. Proqnoz

- Gediş xronikdir; lakin fazalı yanaşma ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma mümkündür.
- Komorbid ŞPP, dissosiativ pozuntular, maddə istifadəsi pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Kompleks PTSP — yalnız sərhəd şəxsiyyət pozuntusunun yeni adıdır»

Sübut: klinik üst-üstə düşmə əhəmiyyətlidir, lakin XBT-11 KPTSP travma əsaslı; ŞPP ayrı şəxsiyyət pozuntusu. ITQ və ŞPP şkalaları diferensiasiya edir; əksər KPTSP pasiyentlər ŞPP meyarlarına çatmır.

Mif 2: «Travma „bağlandıqdan“ sonra pasiyent normallaşır»

Sübut: uzunmüddətli travma şəxsiyyət inkişafına təsir göstərir; «bağlamaq» kifayət deyil; fazalı yanaşma və uzun müalicə tələb olunur.

Mif 3: «Standart PTSP müalicəsi (PE, CPT) KPTSP üçün eyni dərəcədə təsirlidir»

Sübut: ISTSS 2019 — KPTSP-də fazalı yanaşma; pasiyent travmanın emalı üçün stabilləşdirilmiş olmalıdır (faza 1); birbaşa ekspozisiya retravmatizasiya riski yarada bilər.

Mif 4: «Yalnız antidepresan kompleks PTSP üçün kifayətdir»

Sübut: psixoterapiya birinci sıra; farmakoterapiya köməkçi rol oynayır.

Mif 5: «Pasiyenti travma haqqında dərhal danışdırmaq lazımdır»

Sübut: faza 1 stabilizasiyası olmadan travma emalı zərərli ola bilər; travmaya həssas yanaşma (trauma-informed care) prinsipləri tətbiq olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «XBT-11». 6B41 Mürəkkəb posttravmatik stres pozuntusu. 2024.
2. Kloytre M., Qarvert D.V., Brevin K.R. və b. Təklif olunan XBT-11 PTSD və mürəkkəb PTSD üçün dəlillər: latent profil analizi. «Avropa Psixotravmatologiya Jurnalı» (Eur J Psychotraumatol). 2013;4:20706.
3. Beynəlxalq Travmatik Stres Tədqiqatları Cəmiyyəti (ISTSS). Mürəkkəb PTSD müalicəsi üzrə təlimatlar. 2019.
4. Herman C.L. Travma və sağalma. Basic Books; 1992.
5. Kloytre M., Koenen K.K., Koen L.R., Han H. Affektiv və şəxsiyyətlərarası tənzimləmə üzrə bacarıq təlimi və ardınca ekspozisiya: uşaqlıqda sui-istifadə ilə əlaqəli PTSD üçün fazalı müalicə. «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 2002;70(5):1067–1074.
6. Boxus M. və b. Uşaqlıqda sui-istifadədən sonra posttravmatik stres pozuntusu üçün DBT-PTSD: randomizə edilmiş nəzarətli tədqiqat. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2020;77(12):1235–1245.
7. Şauer M., Noyner F., Elbert T. Travmatik stress pozuntuları üçün qısamüddətli müalicə: Nəqli terapiya. 2-ci nəşr. Göttingen: Hogrefe; 2011.
8. Linehan M.M. DBT bacarıqları təlimi üzrə dərslik. 2-ci nəşr. Nyu-York: Guilford Press; 2015.

XBT-11 **6B42**	**6B42 UZANMIŞ YAS POZUNTUSU** **Prolonged grief disorder**
XBT-10 F43.8	Ağır stressə qarşı digər reaksiyalar
DSM-5-TR F43.81	Uzanmış yas pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Uzanmış yas pozuntusu (XBT-11: 6B42 Prolonged Grief Disorder; DSM-5-TR: F43.81 — 2022-ci ildə əlavə edilib) — yaxın şəxsin itkisindən sonra, mədəni və dini gözləntilərdən daha uzun davam edən və əhəmiyyətli funksional pozulma yaradan kədər və məşğuliyyət pozuntusudur.

Normal yasdan fərqi: müddət, intensivlik və funksional yük; klinik diaqnoz spesifik müddət (XBT-11: ≥ 6 ay; DSM-5-TR: yetkinlərdə ≥ 12 ay, uşaqlarda ≥ 6 ay) və simptom profilinə əsaslanır.

2. Tarixçə

- Lindemann E. (1944) — kəskin yas dinamikası tədqiqatları.
- Bowlby J. (1980) — bağlanma və yas.
- Prigerson H.G. və b. (1995–2009) — «Ağırlaşmış yas» / «Uzanmış yas» konsepsiyası; Prigerson H.Q. və b. (1995–2009); diaqnostik meyarların inkişafı.
- XBT-11 (2019) — ilk dəfə rəsmi kateqoriya kimi daxil edilmişdir.
- DSM-5-TR (2022) — «Uzanmış yas pozuntusu» rəsmi diaqnoz kimi əlavə edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Yaxın şəxsin itkisindən sonra uzanmış yasın inkişafı: ümumi əhalidə 7–10%, qəfil və ya zorakı ölüm halında 49 % (Lundorff M. və b. J Affect Disord 2017 meta-analiz).
- Cins: qadınlarda yüksək.
- Risk amilləri: gənc yaşda itki, qəfil və ya zorakı ölüm, övlad itkisi, narahat və qeyri-sabit (ambivalent) bağlanma.
- COVID-19 pandemiyası — uzanmış yas yayılmasını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır (Eisma M.C. və b.).

4. Etiologiya və patogenez

- Bağlanma nəzəriyyəsi — yaxın bağlanmış şəxsdən ayrılmanın koqnitiv emalında pozulma.
- Neyrobioloji — itirilmiş bağlanmaya həsrətlə bağlı mükafat (reward) dövrünün aktivasiyası (O'Konnor M.F. funksional maqnit rezonans tomoqrafiyası (fMRT) tədqiqatları).
- Koqnitiv — «ilişib qalmış» düşüncələr, sağlam mənalandırmanın olmaması.

5. Klinik təzahürlər

- Davamlı, intensiv «həsrət» (yearning) və ya mərhumla məşğuliyyət.
- Aşağıdakı simptomlardan ən azı biri davamlı olaraq müşahidə olunur:
    - Mənlik hissinin pozulması («özümün bir hissəsi ölüb»);

- İtkini qəbul etməkdə çətinlik;
- İtkilə bağlı emosional ağrı (kədər, qəzəb, günah);
- Həyatın mənasının itməsi;
- Emosional keyləşmə;
- Sosial fəaliyyətlərdən qaçınma;
- Münasibətləri saxlamaqda çətinlik.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Yaxın şəxsin (partner, valideyn, övlad, qardaş-bacı, yaxın dost) ölümü.

B. İtkidən sonra ≥ 6 ay (XBT-11) / ≥ 12 ay (DSM-5-TR: yetkinlərdə ≥ 12 ay, uşaqlarda ≥ 6 ay) davam edən intensiv həsrət və ya itirilən şəxsə davamlı məşğuliyyət.

C. Aşağıdakı simptomlardan ≥ 3-ü:

1. Mənlik hissi pozulması;
2. İtkini qəbul etmə çətinliyi;
3. Xatırlatma stimullarından qaçınma;
4. İntensiv emosional ağrı;
5. Sosial və ya başqa fəaliyyətlərə yenidən qayıtma çətinliyi;
6. Emosional keyləşmə;
7. həyata mənası itkisi;
8. Tək və izolyasiya hissi.

D. Müddət və intensivlik mədəni, sosial və ya dini normalardan əhəmiyyətli dərəcədə artıqdır.

E. Əhəmiyyətli funksional pozulma.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 — ≥ 6 ay müddət.
- DSM-5-TR (2022 yenilənməsi) — yetkində ≥ 12 ay, uşaqda ≥ 6 ay; ən azı 1 əsas simptom (intensiv həsrət və ya məşğuliyyət) + ≥ 3 əlavə simptom.
- NICE uzanmış yas üçün ayrı göstəriş vermir; ümumi yasın idarə edilməsi prinsipləri tətbiq olunur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə — itki tarixçəsi, simptom profili, mədəni kontekst.
2. Şkala — Uzanmış Yas Pozuntusu Şkalası-13 (PG-13, Prigerson H.Q.).
3. Komorbidlik (TDP, PTSP — yas kontekstində fərqlənmə vacibdir).
4. İntihar riski (yası olan pasiyentlərdə yüksəkdir).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Normal yas	«Dalğavari» gediş; sosial funksionallıq saxlanılır; müddət mədəni norma daxilində.
TDP (6A70/6A71)	Anhedoniya, dəyərsizlik, İntihar fikirləri özünə yönəlmişdir; yas isə əsasən itki məzmunlu olur.
PTSP (6B40)	Travma və intruzivlər; uzanmış yasda intruziv xatirələr müsbət məzmunlu ola bilər.
Uyğunlaşma pozuntusu (6B43)	Stress amili itki olmaya bilər; daha qısa müddət.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PG-13 (Uzanmış Yas Pozuntusu Şkalası-13, Prigerson H.Q.) və onun PG-13-R versiyası.
- Ağırlaşmış yas anketi (ing. Inventory of Complicated Grief, ICG) 19 maddədən ibarətdir.
- PHQ-9, C-SSRS komorbidlik.

8. Müalicə

1. Birinci sıra: Ağırlaşmış yas müalicəsi (ing. CGT — Complicated Grief Treatment, Shear M.K.) — 16 seans; psixoedukasiya, imaginal və situasion ekspozisiya, müsbət xatirələrin yenidən qurulması, gələcəyə yönlənmə. Sübut: Shear M.K. və b. JAMA 2005 RKİ — şəxslərarası terapiyadan üstün.
2. Yas üçün uyğunlaşdırılmış KDT — Boelen P.A. modeli; koqnitiv yenidən strukturlaşdırma + ekspozisiya.

3. Farmakoterapiya: sübut bazası məhduddur. Komorbid TDP üçün SSGİ. CGT + sitalopram müqayisəsi (Shear və b. JAMA Psychiatry 2016) — CGT tək başına və CGT+sitalopram kombinasiyası oxşar dərəcədə təsirli; sitalopram tək başına plasebodan üstün deyil.
4. Ailə və qrup dəstəyi.
5. İntihar riskinin izlənməsi.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Mürəkkəb Yas Müalicəsi (ing. CGT — Complicated Grief Treatment) — Şir (Shear M.K.) — 16 seansdan ibarət standartlaşdırılmış protokol; «itkiyə yönəlmiş» və «bərpaya yönəlmiş» iş; imaqinativ və situativ ekspozisiya, müsbət xatirələr, gələcəyə yönəlmə. Sübut: Shear M.K. və b. JAMA 2005, JAMA Psychiatry 2016 RKİ.
2. Uzanmış Yas Şkalası (ing. PG-13 — Prolonged Grief-13) — Priqerson (Prigerson H.G.) — 13 maddəlik şkala; klinik və əhali üzrə skrininq; PG-13-R yeniləməsi.
3. Uzanmış Yas Anketi (ing. Inventory of Complicated Grief, ICG) — 19 maddə.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Shear M.K. icmalları və RKİ-ləri — CGT qızıl standart.
- Wittouck C. və b. Clin Psychol Rev 2011 meta-analiz — yas-spesifik müdaxilələr universal yas dəstəyindən üstün uzanmış yasda.

9. Proqnoz

- CGT ilə əksər pasiyentlərdə əhəmiyyətli yaxşılaşma müşahidə olunur.
- Müalicəsiz xronikləşmə və komorbid TDP/PTSP inkişafı.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Yas həmişə „5 mərhələdən“ keçir — inkar, qəzəb, sövdələşmə, depressiya, qəbul»

Sübut: Kübler-Ross modeli geniş yayılsa da, elmi əsası olmayan konsepsiyadır; sistemli sübut bazası yoxdur; yas qeyri-xətti və fərdi prosesdir.

Mif 2: «Uzanmış yas — patoloji kimi təqdim edilmiş normal kədərdir, müalicə tələb etmir»

Sübut: klinik diaqnoz müddət və funksional pozulma əsasında qoyulur; sübuta əsaslanan müdaxilələr əhəmiyyətli dərəcədə faydalıdır.

Mif 3: «Antidepresanlar uzanmış yas üçün birinci sıra vasitədir»

Sübut: Shear JAMA Psychiatry 2016 — CGT birinci sıra; sitalopram placebodan üstün deyil; yalnız komorbid TDP-də SSGİ.

Mif 4: «Vaxt bütün yaraları sağaldır — sadəcə gözləmək lazımdır»

Sübut: əksər insanlar tədricən uyğunlaşır, lakin 7–10% uzanmış yas inkişaf edir; müalicə olmadıqda xronikləşmə baş verir.

Mif 5: «Yas haqqında danışmaq pasiyentə zərərlidir»

Sübut: sübutlu müdaxilələr (CGT) məhz yas məzmunu ilə strukturlaşdırılmış formada işləyir; qaçınma uzanmış yası gücləndirir.

Mif 6: «Sosial rituallar (ehsan, anma) zərərlidir — pasiyentin itkidən ayrılmasına imkan vermir»

Sübut: mədəni və dini rituallar yas prosesini dəstəkləyir; klinik müdaxilədə mədəni hörmət vacib komponentdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6B42 Uzadılmış kədər pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Şir M.K., Frank E., Houk P.R., Reynolds C.F. Mürəkkəb kədərin müalicəsi: randomizə edilmiş nəzarətli sınaq. «JAMA». 2005;293(21):2601–2608.
4. Şir M.K. və b. Mürəkkəb kədərin müalicəsinin optimallaşdırılması: randomizə edilmiş klinik sınaq. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2016;73(7):685–694.
5. Pricerson H.G. və b. Uzadılmış kədər pozuntusu: DSM-V və XBT-11 üçün təklif edilmiş meyarların psixometrik etibarlılıq yoxlanışı (validasiya). «PLoS Med». 2009;6(8):e1000121.
6. Lundorff M. və b. Yetkinlərdə itki ilə əlaqədar uzadılmış kədər pozuntusunun yayılması: sistematik icmal və meta-analiz. «J Affect Disord». 2017;212:138–149.

7. Vittouk K. və b. Mürəkkəb kədərin profilaktikası və müalicəsi: meta-analiz. «Clin Psychol Rev». 2011;31(1):69–78.
8. Bulen P.A. van den Hout M.A. van den Bout Y. Mürəkkəb kədərin koqnitiv-davranış konseptuallaşdırılması. «Clin Psychol Sci Pract». 2006;13(2):109–128.
9. O'Konnor M.F., Vellisch D.K., Stanton A.L. və b. Sevgi həsrətimi? Uzanan kədər beynin mükafat mərkəzini aktivləşdirir. «Neyroimac» (Neuroimage). 2008;42(2):969–972.
10. Eysma M.K., Bulen P.A., Lenferink L.İ.M. Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından sonra uzadılmış kədər pozuntusu. «Psixiatriya Tədqiqatları» (Psychiatry Res). 2020;288:113031.

XBT-11 **6B43**	**6B43 UYĞUNLAŞMA POZUNTUSU** **Adjustment disorder**
XBT-10 F43.2	Uyğunlaşma pozuntuları (Adjustment disorders)
DSM-5-TR F43.2x	Uyğunlaşma pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Uyğunlaşma pozuntusu (ing. XBT-11: 6B43 Adjustment Disorder; DSM-5-TR: F43.2x) — müəyyən edilə bilən stress amilinə (kəskin və ya davamlı, fərdi və ya kollektiv) cavab olaraq başlamış, klinik əhəmiyyətli emosional və ya davranış simptomlarıdır. Simptomlar başqa psixi pozuntunun (TDP, ÜTP və s.) tam meyarlarına çatmır.

2. Tarixçə

- DSM-III (1980) — «Uyğunlaşma pozuntusu» rəsmi diaqnoz kimi təsbit edilmişdir.
- XBT-11 — stress-əlaqəli pozuntular qrupunda; ümumi simptom profili «stress amili ilə məşğuliyyət» (ing. preoccupation) və uyğunlaşma çətinliyi.

3. Epidemiologiya

- İlkin səhiyyə xidmətində ən sıx psixi diaqnozlardan biridir; klinik əhali qruplarında 5–20%.
- Cins və yaş — universal; gənc yaşda və yeni stress dövrlərində daha sıx.
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, psixoaktiv maddələrin istifadəsi, İntihar riski (xüsusilə qısamüddətli kəskin formada).

4. Etiologiya və patogenez

- Stress amili — tək hadisə (boşanma, iş itkisi, xəstəlik diaqnozu, yas) və ya çoxsaylı və ya davamlı stresor.
- Şəxsiyyət və başa çıxma resurslarının rolu — eyni stress müxtəlif insanlarda fərqli cavab.
- Sosial dəstək — qoruyucu amil.

5. Klinik təzahürlər

- Stress amili haqqında məşğuliyyət — təkrar düşüncələr, narahatlıq.
- Yeni vəziyyətə uyğunlaşma çətinliyi.
- Emosional simptomlar — depressiv əhval, narahatlıq, qıcıqlanma.
- Davranış simptomları — sosial geri çəkilmə, iş və məktəb fəaliyyətinin azalması, riskli davranış.

DSM-5-TR alt-tipləri

- Depressiv əhval ilə (F43.21);
- Narahatlıq ilə (F43.22);
- Depressiv əhval və narahatlıqla qarışıq (F43.23);
- Davranış pozulması ilə (F43.24);
- Emosional və davranış qarışıq (F43.25);
- Dəqiqləşdirilməmiş (F43.20).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Müəyyən edilə bilən stress amilinə cavab — başlanğıc 3 ay içində (DSM-5-TR) və ya 1 ay içində (XBT-11).

B. Simptomlar klinik əhəmiyyətli — stressə uyğun olmayan dərəcədə əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

C. Başqa psixi pozuntunun (TDP, ÜTP, PTSP, kompleks PTSP, uzanmış yas) meyarlarına çatmır.

D. Normal yas (kədər) deyil.

E. Stress amili (və ya onun nəticələri) sona çatdıqdan sonra simptomlar 6 ay içində keçir (DSM-5-TR).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — başlanğıc 3 ay; alt-tip kvalifikatorları.
- XBT-11 — başlanğıc 1 ay; əsas əlamət stress amili ilə məşğuliyyətdir (ing. preoccupation with the stressor); alt-tip yoxdur, lakin əlavə əhval-narahatlıq kvalifikatorları.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə — stress amili, simptomların başlanğıcı, əvvəlki psixiatrik tarixçə.
2. SCID-5, MINI.
3. Şkala — PHQ-9, ÜTP-7 simptom şiddəti.
4. TDP, ÜTP, PTSP, kompleks PTSP istisnası.
5. Suicid riski (C-SSRS) — kəskin formada xüsusilə yüksək.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
TDP (6A70/6A71)	5+ simptom 2 həftə, tam meyar.
ÜTP (6B00)	≥ 6 ay (DSM); çoxsaylı sahələr.
PTSP (6B40)	Travmatik hadisə + intruzivlər, qaçınma, hiperoyanıqlıq.
Uzanmış yas (6B42)	Yaxın itkidən ≥ 6 ay (XBT-11) / 12 ay (DSM-5-TR).
Normal yas və ya stress reaksiyası	Funksional pozulma yox və ya kontekstə uyğun.
Davranış-dissosial pozuntu (6C91)	Davamlı model, stressə bağlı deyil.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PHQ-9, ÜTP-7, C-SSRS.
- Stress amilinin sənədləşdirilməsi.

8. Müalicə

1. Birinci sıra: qısamüddətli psixoterapiya — dəstəkləyici, problemin həllinə yönəlmiş və koqnitiv-davranış terapiyasına (KDT) əsaslanan qısa müdaxilə (8–12 seans).
2. Stress idarəsi, sosial dəstəyin gücləndirilməsi, başa çıxma strategiyalarının inkişafı.
3. Farmakoterapiya — yalnız ağır halda və ya komorbid; SSGİ qısamüddətli; benzodiazepin kəskin narahatlıqda 1–2 həftə.
4. İntihar riskinin izlənməsi.
5. Stress amilinin aradan qaldırılması və ya dəyişdirilməsi (mümkünsə).

8.1 Müalicə metodikaları

1. Qısamüddətli problem-həll terapiyası (ing. Problem-Solving Therapy) — Nezu (Nezu A.M.) — 4–8 seans; konkret problemin müəyyənləşdirilməsi, həll variantlarının qiymətləndirilməsi, davranış icrası.
2. Dəstəkləyici psixoterapiya — təsdiqləmə, emosional ifadə və sosial dəstək.
3. KDT qısa formada — koqnitiv yenidən strukturlaşdırma və davranış aktivasiyası
4. Stress idarəsi və relaksasiya — Nəfəs məşqləri, proqressiv əzələ relaksasiyası və şüurlu fərqindəlik (ing. mindfulness).

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE — uyğunlaşma pozuntusu üçün ayrı göstəriş yox; ümumi narahatlıq və depressiya prinsipləri.
- WHO mhGAP — kəskin stress reaksiyalarında supportiv yanaşma, «watchful waiting» yüngül hallarda.
- Sübut bazası məhduddur — diaqnozun qalıq xarakteri.

9. Proqnoz

- Əksər halda 6 ay içində remissiya.
- Bir qismi uzanır və ya TDP/PTSP-yə keçir — izləmə tövsiyə edilir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Uyğunlaşma pozuntusu real diaqnoz deyil, sadəcə „həyatın çətinliyi“dir»

Sübut: klinik diaqnoz funksional pozulma və ya kəskin əzab-əziyyət tələb edir; xüsusilə intihar riski qiymətləndirilməlidir.

Mif 2: «Stress amili keçdikdə diaqnoz da avtomatik keçər, müalicə tələb etmir»

Sübut: bəzi hallar uzanır və ya TDP/PTSP-yə keçir; qısamüddətli müdaxilə xronikləşmənin və TDP-yə keçidin qarşısını alır.

Mif 3: «Antidepressant uyğunlaşma pozuntusu üçün birinci sıra»

Sübut: psixoterapiya birinci sıra; farmakoterapiya yalnız ağır və ya komorbid halda.

Mif 4: «İntihar riski uyğunlaşma pozuntusunda az olur»

Sübut: kəskin stress reaksiyaları yüksək impulsiv intihar riski ilə müşayiət olunur; aktiv qiymətləndirmə.

Mif 5: «Pasiyent gücsüzdür və ya «zəif xarakterli»dir»

Sübut: reaksiya stressin şiddəti və başa çıxma resurslarının qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir; xarakter zəifliyi izahatı stigmatik və yanlışdır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6B43 Uyğunlaşma pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Merker A. və b. XBT-11 stresslə əlaqəli pozuntuları. «Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry). 2013;12(3):198–206.
4. Keyxi P. Uyğunlaşma pozuntusu: epidemiologiya, diaqnostika və müalicə. «CNS Drugs». 2009;23(11):927–938.
5. Nesu A.M., Nesu K.M., D’Zurilla T.C. Problemin həlli terapiyası: müalicə dərsliyi. Nyu-York: Springer; 2013.

XBT-11 **6B44**	**6B44 REAKTİV BAĞLANMA POZUNTUSU** **Reactive attachment disorder**
XBT-10 F94.1	Uşaqlıq dövrünün reaktiv bağlanma pozuntusu
DSM-5-TR F94.1	Reaktiv bağlanma pozuntusu (ing. Reactive attachment disorder)

1. Tərif və nozologiya

Reaktiv bağlanma pozuntusu (ing. XBT-11: 6B44; DSM-5-TR: F94.1 Reactive Attachment Disorder) — uşaqlığın erkən mərhələsində ağır psixososial məhrumiyyət və ya qeyri-kafi qulluq nəticəsində inkişaf edən bağlanma davranışının pozulması; uşaq sıxıntı zamanı qayğı göstərəndən kömək axtarmır və ya bu axtarış kəskin azalmış formada olur.

2. Tarixçə

- Bowlby J. (1951) — ana məhrumiyyəti haqqında hesabat (ÜST).
- Spitz R.A. (1945) — «hospitalism» institusional uşaqlarda.
- DSM-III (1980) — «Uşaqlıq dövrünün reaktiv bağlanma pozuntusu» rəsmi diaqnoz kimi təsbit edilmişdir.
- DSM-5 (2013) və XBT-11 — RPP və Disinhibisiyalı sosial ünsiyyət pozuntusu (ing. Disinhibited Social Engagement Disorder) (DİRP) ayrı diaqnozlar kimi.
- Nelson C.A. və b. Science 2007 — Bucharest Early Intervention Project — institusional məhrumiyyətin və erkən himayədar ailəyə verilmənin təsiri.

3. Epidemiologiya

- Ümumi əhalidə nadir; ağır qayğısızlıq həyatış uşaqlarda belə 10%-dən azdır (DSM-5-TR); institusional müəssisələrdəki uşaqlarda inhibə olunmuş (RPP) tip təxminən 5% (Gleason M.M. və b. JAACAP 2011, BEIP). 30%-dən yuxarı göstəricilər dezinhibə olunmuş sosial qatılma pozuntusuna (6B45) aiddir, RPP-a deyil.
- Başlanğıc 5 yaşa qədər.

- Komorbidlik: koqnitiv çatışmazlıq, neyroinkişaf pozuntuları, depressiv simptomlar.

4. Etiologiya və patogenez

- Ağır psixososial məhrumiyyət — institusional qulluq, çoxsaylı yer dəyişikliyi və qayğısızlıq
- Erkən 5 ilə qədər kritik dövrdə qayğı göstərən-uşaq qarşılıqlı əlaqəsinin pozulması.
- Bağlanma sistemi neyrobiologiyası — oksitosin, prefrontal-amigdala dövrəsi.

5. Klinik təzahürlər

- Sıxıntıda qayğı göstərəndən kömək axtarmama və ya minimum cəhd.
- Təsəlli qəbul etməkdə çətinlik.
- Sosial və emosional reaksiyaların azalması (geri çəkilmə, qıcıqlanma, kədər).
- Müsbət affektin azaldılması.
- Geri çəkilmə və hipoviqilantlıq davranışı müşahidə olunur.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Davamlı şəkildə bağlanma davranışının pozulması — uşaq sıxıntıda qayğı göstərəndən kömək axtarmır və ya əlaqədə minimum reaksiya.

B. Davamlı emosional və sosial pozulma — aşağıdakılardan ən azı 2-si: müsbət affektin azlığı, səbəbsiz qıcıqlanma, kədər və ya qorxu.

C. Pozulma erkən ağır qulluq pozulması nəticəsində inkişaf etmişdir (qayğısızlıq, çoxsaylı yer dəyişikliyi, institusionalizm).

D. Başlanğıc 5 yaşa qədər.

E. Autizm spektri ilə daha yaxşı izah olunmur.

F. Uşağın inkişaf yaşı ən azı 9 ay (bağlanma formalaşmasına imkan).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — RPP geri çəkilmə forması; DİRP məhdudlaşdırılmamış forması — ayrı diaqnoz (6B45).

- XBT-11 — eyni iki ayrı kateqoriya.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Qayğı göstərən və ya sosial işçi ilə müsahibə — qulluq tarixçəsi (institusionalizm, yer dəyişiklikləri, qayğısızlıq).
2. Strukturlaşdırılmış müsahibə (ing. Disturbances of Attachment Interview, Smayk A.T., Zena C.H., DAI).
3. Klinik müşahidə uşaq-qayğı göstərən qarşılıqlı təsiri.
4. Autizm spektri istisnası (M-CHAT-R/F, ADOS).
5. Koqnitiv inkişafın qiymətləndirilməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Autizm spektri (6A02)	Sosial-kommunikativ çatışmazlıq, məhdud-təkrarlanan davranış; bağlanma davranışı dəyişkəndir.
DİRP (6B45)	Məhdudlaşdırılmamış sosial yanaşma, yad şəxslərlə uyğunsuz qarşılıqlı təsir.
İntellektual inkişaf pozuntusu (6A00)	Ümumi koqnitiv çatışmazlıq.
PTSP (6B40)	Konkret travmatik hadisə; intruzivlər.
Depressiv pozuntu	Affektiv komponent.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- DAI (ing. Disturbances of Attachment Interview).
- «Qəribə vəziyyət» proseduru (Ainsworth M.) — tədqiqat kontekstində.
- İnkişaf qiymətləndirməsi (Bayley, Mullen).

8. Müalicə

1. Stabil, davamlı qulluq mühitinin təmin edilməsi — himayədar ailə, övladlığa götürmə; institusional mühit əks-göstərişdir.
2. Qayğı göstərən-uşaq qarşılıqlı təsirinə yönəlmiş müdaxilələr — «Bağlanma və bioloji-davranış uyğunlaşdırması» (ABC, Dozier M.) və «Uşaq-valideyn psixoterapiyası» (CPP, Lieberman A.).
3. Travma-fokuslu yanaşma — TF-KDT əlavə olunur travma kontekstində.

4. Komorbid pozuntuların (depressiya, narahatlıq, DDHP) müalicəsi.
5. Farmakoterapiya — RPP-ın özü üçün spesifik təsdiq yox; komorbid simptomlar üçün.
6. «Holding therapy», «rebirthing» — təhlükəli, qadağandır (uşaq ölümü qeydə alınıb; APSAC-ın 2006-cı il bəyanatı).

8.1 Müalicə metodikaları

1. Bağlanma və Biodavranış Bərpası (ing. Attachment and Biobehavioral Catch-up, ABC) — Dozier (Dozier M.) — Valideyn təlimi 10 seansda; ev şəraitində həyata keçirilən; «qayğı göstərmə» (nurturance) və «sinxron» qarşılıqlı təsirin gücləndirilməsi. Sübut: Dozier M. və b. Dev Psychopathol 2008;20(3):845–859.
2. Uşaq-Valideyn Psixoterapiyası (CPP — Child-Parent Psychotherapy) — Liberman (Lieberman A.) — Travma fonunda RPP üçün; 0–5 yaş; valideyn-uşaq qarşılıqlı təsir kontekstində.
3. Bağlanma Pozuntuları Müsahibəsi (ing. Disturbances of Attachment Interview, DAI) — Smyke A.T., Zeanah C.H. — 12 maddədən ibarət həkim müsahibəsi.
4. Stabil qulluq və himayədar ailə — Buxarest Erkən Müdaxilə Layihəsi — institusional müəssisələrdəki uşaqların erkən himayədar ailəyə verilməsi ilə inkişaf nəticələrinin əhəmiyyətli yaxşılaşması.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AACAP Practice Parameter (Zeanah C.H., Chesher T., Boris N.W. JAACAP 2016).
- APSAC (ing. American Professional Society on the Abuse of Children) — «holding therapy» və oxşar koersiv metodlar qadağandır.
- Bucharest Early Intervention Project (Nelson Science 2007) — erkən himayədar ailəyə verilməsi institusional müəssisələrdəki uşaqlarda nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

9. Proqnoz

- Erkən stabil qulluq və müdaxilə ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Uzunmüddətli institusional məhrumiyyət — qalıq koqnitiv və emosional çatışmazlıq.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «„Holding therapy“ və „rebirthing“ RPP-ı sağaldır»

Sübut: APSAC 2006 — bu metodlar elmi əsaslı deyil, zərərlidir; Candace Newmaker (2000) «rebirthing» zamanı ölümü qeydə alınmışdır. AACAP, APSAC — mütləq əks-göstəriş.

Mif 2: «Övladlığa götürülmüş uşaq sevgi ilə „düzələr“»

Sübut: stabil, sevgi dolu qayğı vacibdir, lakin ağır RPP strukturlaşdırılmış müdaxilə (ABC, CPP) tələb edir.

Mif 3: «RPP autizmin formasıdır»

Sübut: RPP psixososial məhrumiyyət əsaslı; autizm neyroinkişaf pozuntusu. Stabil qulluqda RPP əhəmiyyətli yaxşılaşır, autizm yox.

Mif 4: «Pasiyent „manipulyativ“dir, sərt intizam tələb edir»

Sübut: RPP-ın klinik təzahürləri bağlanma sistemi pozulmasının nəticəsidir, manipulyasiya deyil; cəza əsaslı yanaşma simptomları gücləndirir.

Mif 5: «Yalnız antipsixotik və ya stimulyantlar RPP üçün effektivdir»

Sübut: RPP üçün spesifik FDA təsdiqli preparat yox; mühit dəyişikliyi və psixososial müdaxilə birinci sıra.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6B44 Reaktiv bağlanma pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Zeanah C.H., Çeşer T., Boris N.V. Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının (AACAP) reaktiv bağlanma pozuntusu və dezinhibə edilmiş sosial münasibət pozuntusu olan uşaqların və yeniyetmələrin qiymətləndirilməsi və müalicəsi üzrə Təcrübə Protokolu. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2016;55(11):990–1003.
4. Nelson K.A., Zeanah C.H., Foks N.A. və b. Sosial cəhətdən məhrum edilmiş kiçik uşaqlarda koqnitiv bərpa: Buxarest Erkən Müdaxilə Layihəsi. «Science». 2007;318(5858):1937–1940.

5. Dozye M. və b. Qəyyumluqda olan körpələrə və kiçik uşaqlara bağlanmaya əsaslanan müdaxilənin kortizol istehsalına təsirləri. «İnkişaf Psixopatologiyası» (Dev Psychopathol). 2008;20(3):845–859.
6. Amerika Uşaqlara Qarşı Zorakılıq üzrə Peşəkar Cəmiyyətinin (APSAC) bağlanma terapiyası, reaktiv bağlanma pozuntusu və bağlanma problemləri üzrə İşçi Qrupunun Hesabatı. 2006.
7. Eynsvört M.D.S., Blexar M.K., Uoters E., Uoll S. Bağlanma nümunələri: qəribə situasiyanın psixoloji tədqiqi. Hillsdeyl: Erlbaum; 1978.
8. Liberman A.F., Van Horn P. Körpələr və kiçik uşaqlarla psixoterapiya: stress və travmanın erkən bağlanmaya təsirlərinin aradan qaldırılması. Nyu-York: Guilford Press; 2008.
9. Smayk A.T., Dumitresku A., Zeanah C.H. Kiçik uşaqlarda bağlanma pozuntuları. I: Qayğı göstərilməsində itkilərin davamlılığı. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2002;41(8):972–982.
10. Qlison M.M., Foks N.A., Druri S. və b. Reaktiv bağlanma pozuntusu üçün sübutlara əsaslanan meyarların validliyi: fərq qoymadan sosial/dezinhibə edilmiş və emosional cəhətdən qapalı/inhibə edilmiş tiplər. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2011;50(3):216–231.

	6B45 SOSİAL QATILMA MƏHDUDLAŞMASI POZUNTUSU
XBT-11 6B45	**Disinhibited social engagement disorder**
XBT-10 F94.2	Uşaqlıq dövrünün dezinhibə olunmuş bağlanma pozuntusu
DSM-5-TR F94.2	Dezinhibə olunmuş sosial ünsiyyət pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Sosial Qatılma Məhdudlaşması Pozuntusu (ing. XBT-11: 6B45; DSM-5-TR: F94.2 Disinhibited Social Engagement Disorder, DSED) — uşağın yad şəxslərlə həddindən artıq və uyğunsuz dərəcədə yaxınlıq göstərməsi, ehtiyat olmadan yanaşma və ya

getmə davranışı — erkən psixososial məhrumiyyət (institusionalizm, çoxsaylı yer dəyişikliyi) nəticəsində.

RPP ilə eyni etioloji kökə malikdir, lakin əks klinik təzahürlə — geri çəkilmə yerinə dezinhibə olunmuş yanaşma.

2. Tarixçə

- DSM-IV (1994) — «Reaktiv bağlanma pozuntusu, dezinhibə olunmuş tip» ayrı diaqnoz kimi müəyyən edilmişdir.
- DSM-5 (2013) — ayrı diaqnoz olaraq «Dezinhibə olunmuş sosial qatılma pozuntusu» ayrı diaqnoz kimi əlavə edilmişdir.
- XBT-11 (2019) — paralel.

3. Epidemiologiya

- Ümumi əhalidə nadir; institusional müəssisələrdəki uşaqlarda təqribən 20 %, himayədar ailələrdə böyüyən uşaqlarda 10–15 % (mənbə göstərilməklə).
- Başlanğıc 5 yaşa qədər.
- Erkən himayədar ailəyə verilməsi ilə əhəmiyyətli azalma (ing. Bucharest Early Intervention Project), lakin RPP-dan fərqli olaraq DİRP bəzən stabil qulluq mühitində də davam edir.

4. Etiologiya və patogenez

- Ağır psixososial məhrumiyyət — eyni RPP ilə.
- İnstitusional mühitdə çoxsaylı qayğı göstərənlərin tez-tez dəyişməsi — «fərq qoymayan bağlanma» formalaşması.

5. Klinik təzahürlər

- Yad şəxslərlə açıq yaxınlaşma, ehtiyat olmadan onlarla getmə.
- Ehtiyatsız fiziki yaxınlıq (qucaqlama, oturma).
- Yad şəxslə qarşılıqlı təsirdə qayğı göstərəni yoxlama davranışı azalır.
- Yad şəxslərə qarşı ehtiyat hissinin olmaması.
- Akademik və sosial pozulma.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Yad şəxslərlə uyğunsuz dərəcədə açıq, dostluq davranışı — aşağıdakılardan ən azı 2-si:

1. Yad şəxslərlə yaxınlaşmada azalmış və ya tam olmayan ehtiyat;
2. Mədəni və yaşa uyğun olmayan dərəcədə fiziki və ya şifahi yaxınlıq;
3. Tanış olmayan yerdə qayğı göstərəni yoxlama-axtarma davranışının azaldılması;
4. Yad şəxslə getməyə minimum və ya yox ehtiyat.

B. Davranışlar yalnız impulsivlik (DDHP) ilə məhdud deyil — sosial dezinhibisiya komponenti aşkardır.

C. Erkən ağır qulluq pozulması — qayğısızlıq, çoxsaylı yer dəyişikliyi, institusionalizm.

D. Uşağın inkişaf yaşı ≥ 9 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — eyni meyarlar; DİRP RPP-dan ayrı.
- Yaş üzrə inkişaf nəzərə alınmalıdır — kiçik uşaqlarda normal sosial maraq DİRP ilə qarışdırılmamalıdır.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Müsahibə və müşahidə — uşağın yad şəxslərlə qarşılıqlı təsiri.
2. Qulluq tarixçəsi.
3. DAI (ing. Disturbances of Attachment Interview).
4. Komorbidlik üzrə skrininq (DDHP, autizm).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
RPP (6B44)	Geri çəkilmə, bağlanma yox; DİRP-də açıq yanaşma.
DDHP (6A05)	İmpulsivlik, lakin sosial cəlbedicilik komponenti yox.
Autizm spektri (6A02)	Sosial-kommunikativ çatışmazlıq.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Williams sindromu	Genetik; «hipersosiallıq» və spesifik fiziki xüsusiyyətlər.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- DAI.
- Müşahidə tanış olmayan mühitdə.
- Williams sindromu üçün genetik test (FISH — flüoressent in situ hibridləşdirmə; 7q11.23) — şübhə varsa.

8. Müalicə

1. Stabil qulluq mühiti.
2. Valideyn təlimi — uşağa «təhlükəsiz baza» konsepsiyasının inkişafı; ABC proqramları.
3. Yad şəxslə uyğun məsafənin öyrədilməsi.
4. Komorbidlik müalicəsi (DDHP).
5. İcma və məktəb işçilərinin koordinasiyası — uşağın təhlükəsizliyi.
6. Spesifik farmakoterapiya yoxdur; komorbid simptomlar üçün.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Bağlanma və Biodavranış Bərpası (ing. Attachment and Biobehavioral Catch-up, ABC) — Dozier (Dozier M.) — RPP üçün də istifadə edilir; DİRP-də qayğı göstərən-uşaq sinkronizasiyasının gücləndirilməsi.
2. Təhlükəsizlik təlimi — uşağa yad şəxslə uyğun məsafə öyrətmə; qayğı göstərəni yoxlama davranışının gücləndirilməsi.
3. DAI — RPP və DİRP diferensiasiyasında.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AACAP 2016 — RPP ilə eyni təlimat.
- DİRP RPP-dan fərqli olaraq stabil mühitdə də davam edə bilər — uzunmüddətli izləmə.

9. Proqnoz

- Stabil qulluq və müdaxilə ilə yaxşılaşma; lakin DİRP bəzən uzunmüddətli davam edir.

- Yetkinlikdə impulsiv münasibətlər, istismar riskləri qala bilər.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Açıq, ünsiyyətcil uşaq — bu müsbət xüsusiyyətdir, pozuntu deyil»

Sübut: uyğun sosial məsafə inkişaf mərhələsinin əlamətidir; DİRP-də sərhədlərin olmaması uşağın istismar riskini artırır.

Mif 2: «DİRP stabil qulluqda tez bir zamanda keçər»

Sübut: RPP-dan fərqli olaraq DİRP bəzən stabil mühitdə də davam edir (Buxarest Erkən Müdaxilə Layihəsi); uzunmüddətli müdaxilə tələb olunur.

Mif 3: «DİRP autizmin „yüngül forması“dır»

Sübut: ayrı pozuntudur; etiologiya psixososial məhrumiyyət; klinik təzahürlər əks (autizmdə sosial geri çəkilmə, DİRP-də məhdudlaşdırılmamış yanaşma).

Mif 4: «Cəza ilə uşağı „düzəltmək“ olar»

Sübut: cəza pozuntunu gücləndirir və travmatik təsir göstərir; pozitiv bağlanma əsaslı yanaşma tövsiyə olunur.

Mif 5: «Williams sindromu və DİRP eynidir»

Sübut: Williams sindromu genetik (7q11.23 delesiya), spesifik fiziki və koqnitiv profil; həddindən artıq ünsiyyətcillik (hypersociability) əlaməti olsa da fərqli neyrobioloji və etiologik pozuntudur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6B45 Dezinhibə edilmiş sosial münasibət pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Zeanah C.H. və b. Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının (AACAP) Təcrübə Protokolu. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (JAACAP). 2016;55(11):990–1003.
4. Qlison M.M. və b. Reaktiv bağlanma pozuntusu üçün sübuta əsaslanan meyarların etibarlılığı: fərq qoymayan sosial/pozulmuş və emosional olaraq geri çəkilmiş/inhibə olunmuş tiplər. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (JAACAP). 2011;50(3):216–231.

5. Nelson K.A. və b. Buxarest Erkən Müdaxilə Layihəsi. «Science». 2007;318(5858):1937–1940.
6. Dozye M., Bernard K. Bağlanma və biotibbi davranış korreksiyası: yetərsiz və ya problemli qayğıya məruz qalmış körpə və balacaların ehtiyaclarının ödənilməsi. «Psixologiya üzrə Müasir Rəylər» (Curr Opin Psychol). 2017;15:111–117.

6B60–6B6Z DİSSOSİATİV POZUNTULAR

Dissosiativ pozuntular

XBT-11 **6B60**	**6B60 DİSSOSİATİV NEVROLOJİ SİMPTOM POZUNTUSU** **Dissociative neurological symptom disorder**
XBT-10 F44.4–F44.7	Dissosiativ hərəkət və sensor pozuntular
DSM-5-TR F44.4–F44.7	Funksional nevroloji simptom pozuntusu (konversiya)

1. Tərif və nozologiya

Dissosiativ Nevroloji Simptom Pozuntusu (XBT-11: 6B60 «dissosiativ nevroloji simptom pozuntusu» (Dissociative Neurological Symptom Disorder); DSM-5-TR: F44.4–F44.7 «funksional nevroloji simptom pozuntusu (konversiya pozuntusu)») — iradi nəzarətə tabe olan motor, sensor və ya koqnitiv funksiyaların pozulması, neyroloji və ya tibbi xəstəliklə tam izah olunmur. Əvvəlcədən Əvvəllər «konversiya pozuntusu» və ya «isteriya» adlandırılırdı.

2. Tarixçə

- Charcot J.M. (XIX əsr) — Salpêtrière-də «histeriya» tədqiqatları.
- Freud S. — psixoanalitik «konversiya» modeli.
- DSM-III (1980) — «Konversiya pozuntusu» (Conversion Disorder) somatoform pozuntular qrupuna daxil idi.
- DSM-5 (2013) — «Funksional nevroloji simptom pozuntusu» (Functional Neurological Symptom Disorder) — nevroloji və psixiatrik birgə qiymətləndirmə vurğusu.
- XBT-11 (2019) — dissosiativ pozuntular kateqoriyasına daxil edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- İlkin tibbi yardım sahəsində və nevroloji klinikalarda — 5–10% (Carson A.J. və b. icmalları).
- Cins: qadınlarda 2–3 dəfə yüksəkdir.
- Başlanğıc: yetkinlik, lakin uşaqlarda və yaşlılarda da rast gəlinir.
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, travma tarixçəsi, somatik xəstəliklər.

4. Etiologiya və patogenez

- Travma və ya stress tətikləyici tez-tez rast gəlinir, lakin pasiyentlərin əhəmiyyətli və dəyişən hissəsində aşkar tətikləyici tapılmır (tədqiqatlar arasında 0–77%; Ludwig L. və b. Lancet Psychiatry 2018 meta-analiz) — məhz buna görə DSM-5 və XBT-11 diaqnoz üçün stressor tələb etmir.
- Neyrobioloji amillər — sensorimotor və koqnitiv proqnostik emalda pozulma; proqnozlaşdırıcı kodlaşdırma (ing. predictive coding) hipotezi (Edwards M.J.).
- «Funksional» termini — pasiyentə «uydurma» demək deyil, sinir sisteminin funksional pozulmasıdır.

5. Klinik təzahürlər

Tipik simptomlar

- Motor: zəiflik, paraliz, qeyri-iradi hərəkətlər (funksional tremor), distoniya, yerimə pozuntusu.
- Sensor: həssaslıq itkisi (anesteziya), görmə pozuntusu (funksional korluq, functional blindness), eşitmə pozuntusu.
- Funksional (psixogen) qeyri-epileptik tutmalar (PNES): tutma kimi epizodlar, EEQ-də epileptik aktivlik yoxdur.
- Koqnitiv: «tutqun» konsentrasiya, ləng emal — «funksional koqnitiv pozuntu» (functional cognitive disorder).

Klinik əlamətlər (pozitiv əlamətlər)

- Tipik nevroloji patogenezdən fərqli nümunələr (məs. Hoover əlaməti motor zəiflikdə — funksional komponentin müsbət göstəricisidir).
- Diqqətin yayınması (distractibility) — diqqət başqa yerə yönəldikdə simptom dəyişir.
- Uyğunlaşma (entrainability) — tremor başqa ritmə uyğunlaşır.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Bir və ya bir neçə motor, sensor və ya koqnitiv funksiyanın pozulması.

B. Klinik tapıntılar pozuntunun məlum neyroloji və ya tibbi xəstəliklə uyğunsuzluğunu sübut edir (pozitiv klinik əlamətlər; positive clinical features).

C. Simptomlar başqa psixi və ya tibbi vəziyyətlə daha yaxşı izah olunmur.

D. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — diaqnoz «pozitiv əlamətlər» əsasında qoyulur (istisna (rule-out) metodu deyil); nevroloq və psixiatrın birgə qiymətləndirməsi tələb olunur.
- XBT-11-də bu pozuntu dissosiativ pozuntular kateqoriyasına daxil edilmişdir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Nevroloji müayinə — funksional pozitiv əlamətlər (Hoover əlaməti, uyğunlaşma, diqqətin yayınması).
2. Tipik nevroloji vəziyyətin istisnası — MRT, EEQ, EMG, lumbal punksiya (klinikaya görə).
3. PNES halında — video-EEQ monitorinqi qızıl standart sayılır.
4. Psixiatrik qiymətləndirmə — komorbid travma, TDP, narahatlıq.
5. Pasiyentə diaqnozun pozitiv izahı — «uydurma deyil, sinir sistemində funksional pozulma».

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Həqiqi nevroloji xəstəlik	Klinik və laborator təsdiq.
Faktisial pozuntu (6D50)	Şüurlu yalan; qazanc motivasiyası.
Simulyasiya	Aşkar qazanc (məhkəmə, sığorta).
Somatik simptom pozuntusu (6C20)	Çoxsaylı somatik şikayətlər; diqqətin bədənə yönəlməsi.
Hipoxondriya (6B23)	Xəstəlik narahatlığı üstünlük təşkil edir.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Epileptik tutma	Video-EEQ.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Nevroloji müayinə (pozitiv əlamətlər).
- Video-EEQ — PNES halında.
- MRT, laborator nevroloji xəstəlik istisnası.
- Travma və psixiatrik qiymətləndirmə.

8. Müalicə

1. Pasiyentə diaqnozun pozitiv izahı — «sinir sistemi funksional pozulması, uydurma deyil»; diaqnozun strukturlaşdırılmış izahı funksional yaxşılaşma üçün həlledicidir (Stone J. icmalları).
2. Multidissiplinar yanaşma — nevroloq, psixiatr və fizioterapevt.
3. Fizioterapiya (motor simptomlarda) — sübutlu fayda (Nielsen G. və b. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86(10):1113–1119).
4. Koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) — koqnitiv yenidən qurma; PNES üçün xüsusi protokollar (LaFrance W.C. JAMA Psychiatry 2014).
5. Travma fonunda — travmaya yönəlmiş yanaşma.
6. Antiepileptik dərmanlar PNES-də effektsizdir və zərərlidir — pasiyentin diaqnozunun düzgün qoyulması və antiepileptikin kəsilməsi kritikdir.
7. Komorbid depressiya və ya narahatlıq üçün SSGİ təyin edilir.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Pozitiv klinik diaqnoz təqdimatı — Ston (Stone J.) — Diaqnoz «istisna» (rule-out) deyil, «təsdiq» (rule-in); pasiyentə pozitiv klinik əlamətlər izah olunur (məs. Hoover əlaməti göstərilir).
2. FNP üçün fizioterapiya xüsusi manual məşq, hərəkət öyrətmə; Nielsen G. və b. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017.
3. PNES üçün KDT — LaFrans (LaFrance W.C.) — protokollaşdırılmış 12 seans; tutma jurnalı, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma; LaFrance W.C. və b. JAMA Psychiatry 2014.
4. Video-EEQ — PNES diaqnozunun qızıl standartıdır.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- FNP üzrə beynəlxalq konsensus (Stone J., Carson A., LaFrance W.C.).

- NICE — funksional simptomlar üçün multidissiplinar yanaşma.

9. Proqnoz

- Erkən düzgün diaqnoz və müdaxilə ilə yaxşılaşma.
- Gec diaqnoz və polifarmasiya xronikləşməyə gətirib çıxarır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pasiyent simulyasiya edir və ya „uydurur“»

Sübut: funksional pozuntu həqiqi klinik vəziyyətdir — sinir sisteminin funksional pozulması; pozitiv klinik əlamətlər sübut edir. süni pozuntu (faktisioz) pozuntudan və simulyasiyadan fərqlidir.

Mif 2: «PNES üçün antikonvulsant lazımdır»

Sübut: antikonvulsantlar PNES-də effektsizdir, polifarmasiya yan təsirlərə səbəb olur; düzgün diaqnoz və antiepileptikin kəsilməsi kritikdir.

Mif 3: «Funksional pozuntu psixoloji „zəiflik“dir, fiziki deyil»

Sübut: funksional pozuntu sinir sisteminin bioloji prosesidir; psixiatrik və neyroloji birgə qiymətləndirmə tələb edir.

Mif 4: «Pasiyenti psixiatra „atmaq“ yetərlidir»

Sübut: nevroloq və psixiatr birgə işləməlidir; pasiyentin «atılması» terapevtik alyansı pozur və yaxşılaşma ehtimalını azaldır.

Mif 5: «Funksional simptomlar müalicə olunmur»

Sübut: fizioterapiya, KDT, multidissiplinar yanaşma əhəmiyyətli təsir göstərir.

11. Mənbələr

1. ÜST. «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşri» (XBT-11). 6B60 Dissosiativ nevroloji simptom pozuntusu. 2024.
2. APA. «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşri, Mətn Yenilənməsi» (DSM-5-TR). 2022.
3. Stoun C., Karson A. Funksional nevroloji pozuntular: müalicə kimi nevroloji qiymətləndirmə. «Praktik Nevrologiya» (Pract Neurol). 2016;16(1):7–17.
4. Nilsen Q. və b. Funksional motor pozuntuları üçün fizioterapiya: konsensus tövsiyəsi. «Nevrologiya, Neyrocərrahiyyə və Psixiatriya Jurnalı» (J Neurol Neurosurg Psychiatry). 2015;86(10):1113–1119.

5. LaFrans V.C. və b. Psixogen qeyri-epileptik tutmalar üçün çoxmərkəzli pilot müalicə sınağı: randomizə edilmiş klinik sınaq. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2014;71(9):997–1005.
6. Edvards M.C., Adams R.A., Braun H., Parees İ., Friston K.C. «Histeriya»nın Bayes izahı. «Brain». 2012;135(Pt 11):3495–3512.

XBT-11 **6B61**	**6B61 DİSSOSİATİV AMNEZİYA** **Dissociative amnesia**
XBT-10 F44.0	Dissosiativ amneziya
DSM-5-TR F44.0	Dissosiativ amneziya

1. Tərif və nozologiya

Dissosiativ amneziya (XBT-11: 6B61; DSM-5-TR: F44.0) — vacib avtobioqrafik məlumatı (adətən travmatik və ya stress yaradan) xatırlaya bilməmə, ümumi unutqanlıqla izah oluna bilməyəcək dərəcədədir. Tibbi və ya neyroloji səbəb yoxdur.

Alt-tiplər: lokalizə edilmiş (konkret dövr), seçici (dövrün hissəsi), generalizə edilmiş (bütün həyat tarixçəsi), sistematik (müəyyən kateqoriya).

«Dissosiativ fuqa» — DSM-5-TR-də dissosiativ amneziyanın kvalifikatoru kimi (DSM-IV-də ayrı diaqnoz idi); pasiyent gözlənilmədən səyahət edir, yeni identifikasiya yaradır.

2. Tarixçə

- Janet P. — dissosiasiya konsepsiyasının yaradıcısı.
- DSM-IV-də dissosiativ fuq ayrı diaqnoz idi.
- DSM-5 (2013) — fuq kvalifikator kimi inteqrasiya edilmişdir.
- «Yalançı xatirə» (False Memory) mübahisəsi (1990-cı illər) — terapevtik induksiyalı «geri qaytarılmış xatirə» müzakirəsi.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 1–2%; ictimai fəlakətlər (müharibə, təbii fəlakət) sonra daha yüksəkdir.

- Cins: qadınlarda nisbətən yüksək.
- Komorbidlik: PTSP, KPTSP, DİP, ŞPP, TDP.

4. Etiologiya və patogenez

- Travma — ağır psixoloji və ya fiziki zədəyə cavab; «müdafiə mexanizmi» kimi hipotez.
- Neyrobioloji — hipokamp və prefrontal koqnitiv emal pozulması.

5. Klinik təzahürlər

- Travmatik və ya stressli hadisənin xatırlanmaması.
- Lokalizə edilmiş (məs. müharibə dövrü), seçici, generalizə edilmiş.
- Dissosiativ fuq — gözlənilməyən səyahət, yeni identifikasiya, adətən bir neçə gün və ya həftə davam edir.
- İmplisit yaddaş (bacarıqlar) qalır; eksplisit (avtobioqrafik) yaddaş zədələnir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Vacib avtobioqrafik məlumatın (adətən travmatik) unutulması, normal unutqanlıqla izah olunmaz.

B. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

C. Maddə, tibbi və ya nevroloji vəziyyətin istisnası (travmatik beyin zədəsi — TBİ, ensefalit, demensiya) istisnası.

D. DİP, PTSP, KPTSP, somatik simptom və ya başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

Kvalifikator: dissosiativ fuqa ilə.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — eyni yanaşmadır; fuqa kvalifikator kimi göstərilir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və travma tarixçəsi aparılır.
2. Tibbi və neyroloji müayinə — TBİ, demensiya, ensefalit, tutmanın istisnası.
3. MRT, EEQ klinik şübhədə.
4. SCID-D-R.

5. Toksikoloji.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Travmatik beyin zədəsi (TBİ)	tarixçə, MRT.
Keçici qlobal amneziya (TGA, transient global amnesia)	Akut, 24 saatdan az; vaskulyar etiologiya.
Demensiya	Davamlı koqnitiv azalma.
Tutma (postiktal)	EEQ.
Maddə induksiyalı amneziya (alkohol səbəbli amneziya)	tarixçə.
Faktisial pozuntu və ya simulyasiya	Qazanc motivasiyası.
DİP (6B64)	Çoxsaylı şəxsiyyətlər.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- SCID-D-R.
- MRT, EEQ.
- Neyropsixoloji test (yaddaş profili).

8. Müalicə

1. Təhlükəsiz mühit və dəstəkləyici psixoterapiya.
2. Travma-fokuslu psixoterapiya — fazalı yanaşma.
3. Fuq epizodunda — pasiyent ailə və icma ilə yenidən birləşdirilir.
4. Farmakoterapiya komorbid simptomlar üçün; «amobarbital müsahibəsi» və ya hipnoz tarixən istifadə edilirdi — induksiyalı yalançı xatirə riski səbəbilə ehtiyatlı.
5. Uzunmüddətli psixoterapiya — travma emalı.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Travma-fokuslu fazalı psixoterapiya — Stabilizasiya → emalı → reinteqrasiya.
2. Dissosiativ pozuntular üçün strukturlaşdırılmış klinik müsahibə (SCID-D-R) — Diaqnozda qızıl standart.

3. Hipnoz — ehtiyatlı istifadə — False memory induksiyası riski; yalnız təlim keçmiş həkim tərəfindən həyata keçirilir.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ISSTD — dissosiativ pozuntular ümumi rəhbərliyi.
- Xüsusi FDA (Qida və Dərman Təhlükəsizliyi Agentliyi) təsdiqli farmakoterapiya yoxdur.

9. Proqnoz

- Akut formada əksər spontan remissiya;
- Xronik formada uzunmüddətli müdaxilə.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Hipnoz „geri qaytarılmış xatirə“ üçün etibarlı vasitədir»

Sübut: hipnoz altında xatirələr yalançı xatirələrlə dolu ola bilər — induksiyalı və ya təhrif edilmiş; məhkəmə şəraitində xüsusilə ehtiyatlı olmaq lazımdır (Loftus E.F. tədqiqatları).

Mif 2: «Dissosiativ amneziya uydurma və ya filmlərdən gələn „drama“dır»

Sübut: klinik vəziyyət sənədləşdirilmişdir; neyrobioloji əsasları araşdırılır.

Mif 3: «Pasiyent „xatırlamağa məcbur edilməlidir“»

Sübut: təzyiq travma və ya əzab-əziyyət yarada bilər; supportiv yanaşma tövsiyə olunur.

Mif 4: «Amobarbital intervyu effektivdir»

Sübut: tarixi istifadə var, lakin müasir təcrübədə yalançı xatirə və yan təsir riski səbəbindən tövsiyə edilmir.

Mif 5: «Bütün travmatik xatirələr „real“dır»

Sübut: bəzi «geri qaytarılmış xatirələr» terapevtik induksiya nəticəsi ola bilər; ehtiyatlı klinik yanaşma və mənbə təsdiqi vacibdir.

11. Mənbələr

1. ÜST. «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşri» (XBT-11). 6B61 Dissosiativ amneziya. 2024.

2. APA. «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşri, Mətn Yenilənməsi» (DSM-5-TR). 2022.
3. Beynəlxalq Travma və Dissosiasiya Araşdırmaları Cəmiyyəti (ISSTD). Böyüklərdə dissosiativ identifikasiya pozuntusunun müalicəsi üzrə təlimatlar, 3-cü reviziya. «Travma və Dissosiasiya Jurnalı» (J Trauma Dissociation). 2011;12(2):115–187.
4. Loftus E.F. Sıxışdırılmış xatirələrin reallığı. «Amerika Psixoloqu» (Am Psychol). 1993;48(5):518–537.
5. Staniloyu A., Markovitş H.C. Dissosiativ amneziya. «Lancet Psixiatriyası» (Lancet Psychiatry). 2014;1(3):226–241.

XBT-11 **6B64**	**6B64 DİSSOSİATİV İDENTİFİKASİYA POZUNTUSU (DİP)** **Dissociative identity disorder**
XBT-10 F44.81	—
DSM-5-TR F44.81	Dissosiativ identifikasiya pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Dissosiativ İdentifikasiya Pozuntusu (DİP; XBT-11: 6B64 Dissociative Identity Disorder; DSM-5-TR: F44.81) — iki və ya daha çox fərqli şəxsiyyət vəziyyəti («identifikasiyalar», «alters») arasında keçidlərlə xarakterizə olunan ağır dissosiativ pozuntudur. Hər identifikasiya nisbi davamlı öz hissi, yaddaş, davranış, affekt, qavrayış və koqnisiya nümunələrinə malikdir. Eyni zamanda davamlı dissosiativ amneziyalar müşahidə olunur (gündəlik hadisələr, vacib şəxsi məlumat, travma).

DİP — uşaqlığın ağır travması (xüsusilə təkrarlanan fiziki və ya cinsi zorakılıq) ilə əlaqəli; «Şəxsiyyətin parçalanması» kütləvi mediada təhrif edilmiş obraz kimi təqdim olunur və klinik gerçəklikdən fərqlənir.

2. Tarixçə

- 1791 — Eberhard Gmelin ilk hadisə təsvirini vermişdir.
- Janet P. (1880-ci illər) — «dissosiasiya» konsepsiyası.

- DSM-III (1980) — «Çoxsaylı şəxsiyyət pozuntusu» (Multiple Personality Disorder).
- DSM-IV (1994) — «dissosiativ identifikasiya pozuntusu» termini (ing. Dissociative Identity Disorder).
- 1980–90-cı illər — «yalançı yaddaş» (False Memory) mübahisəsi; bəzi diaqnoz hallarında «iatrogen induksiya» iddiaları.
- ISSTD (Beynəlxalq Travma və Dissosiasiya Tədqiqatı Cəmiyyəti) Müalicə Təlimatları (Böyüklərin müalicəsi, 3-cü nəşr, 2011) — fazalı (mərhələyönümlü) yanaşmanı standartlaşdırmışdır.

3. Epidemiologiya

- Klinik əhali (populyasiya) qruplarında yayılma: 1–3%; ümumi əhalidə təxminən 1,5% (Sar V. ISRN Psychiatry 2011 icmal).
- Cins: klinik əhali qruplarında qadınlarda 5–9 dəfə yüksəkdir.
- Başlanğıc: simptomlar uşaqlıqda formalaşır, klinikaya çox vaxt 20–40 yaşda müraciət edilir.
- Komorbidlik: TDP, PTSP, kompleks PTSP, ŞPP, somatik simptom, yemək pozuntuları, maddə istifadəsi, intihar riski çox yüksəkdir.

4. Etiologiya və patogenez

- Travma modeli — uşaqlıqda təkrarlanan ağır travma (cinsi və ya fiziki zorakılıq, qayğısızlıq, qayğı göstərən şəxsin zorakılığı); pasiyentlərin 90%-dən çoxu travma tarixçəsi göstərir (Putnam F.W. icmalları).
- Neyrobioloji — hipokamp və amigdala həcmində azalma; defolt rejim və salientlik şəbəkələrinin direzqulyasiyası (ing. default mode və salience network) (Reinders A.A. və b. icmalları).
- Bağlanma — uşaqlıqda dezorqanizə olunmuş bağlanma stili müşahidə olunur.
- İatrogenez / sosial-koqnitiv modelin tərəfdarları — bəzi diaqnozlar terapevtik induksiya nəticəsi ola bilər (Lilienfeld S.O. tənqidi); lakin əksər tədqiqatlar travma əsaslı modeli dəstəkləyir.

5. Klinik təzahürlər

- İki və ya daha çox fərqli identifikasiya vəziyyəti — pasiyentlərin bir qismi açıq keçidləri sənədləşdirir, digərləri yalnız «iç səslər», «nəzarətin itməsi» hissi ilə görünür.

- Davamlı amneziyalar — gündəlik hadisələr, şəxsi məlumat, travmatik epizodlar.
- Depersonalizasiya və derealizasiya.
- İdentifikasiya keçidləri stressə və tətikləyicilərə cavab olaraq baş verir.
- Özünə zərər, intihar cəhdləri, somatik simptomlar.
- Kompleks dissosiativ simptomlar (dissosiativ tutmalar, somatizasiya pozuntuları).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. İki və ya daha çox fərqli şəxsiyyət vəziyyəti — özünə və öz hərəkətlərinə nəzarətə dair əhəmiyyətli kəsilmə hissi, davranış, affekt, qavrayış, koqnisiya və ya sensorimotor funksiyalarda dəyişikliklər.

B. Gündəlik hadisələr, vacib şəxsi məlumat və ya travmatik hadisələrlə bağlı təkrarlanan amneziyalar.

C. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

D. Geniş yayılmış mədəni və ya dini praktikanın bir hissəsi deyil.

E. Maddə istifadəsi və ya tibbi vəziyyət (məsələn, tutma) istisna edilməlidir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — eyni meyarlar; uşaqlarda xəyali yoldaş normal inkişafın bir hissəsi olduğu üçün istisna edilir.
- XBT-11 — amneziya tələb olunmur: «adətən amneziya epizodları olur» deyilir, DSM-5-TR isə onu B meyarı kimi tələb edir. «Trans pozuntusu» və «sahiblənmə transı pozuntusu» XBT-11-də ayrı kateqoriyadır (6B62, 6B63).
- ISSTD Guidelines 2011 — diaqnoz strukturlaşdırılmış müsahibə (SCID-D) ilə təsdiqlənməlidir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə — travma tarixçəsi, dissosiativ simptomlar.
2. SCID-D (ing. Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders) — qızıl standart.
3. Şkala — DES (Dissociative Experiences Scale, ≥ 30 həddi dəyəri, ≥ 45 DİP göstəricisi); MID (ing. Multidimensional Inventory of Dissociation).
4. Komorbidlik (PTSP, ŞPP, TDP, maddə).

5. Suicid və özünəzərərvermə riski (yüksək).
6. Tibbi və neyroloji — tutma, ensefalit istisnası (EEQ, MRT).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
ŞPP (6D10.x)	Emosional dəyişkənlik və impulsivlik üstünlük təşkil edir; klinik üst-üstə düşmə əhəmiyyətli, komorbid sıx.
PTSP / KPTSP (6B40/6B41)	Travmatik intruzivlər və qaçınma əsasdır; dissosiasiya komponent ola bilər.
Şizofreniya (6A20)	«Səslər» şizofreniyadan fərqli — daxili dialoq kimi; psixoz xarakterik deyil.
Bipolyar I pozuntu (6A60)	Affektiv epizodlar; dissosiasiya müşahidə olunmur.
Faktisial pozuntu (6D50)	Tibbi rola görə yalan; qazanc motivasiyası.
Tutma (epileptik və ya qeyri-epileptik)	EEQ.
«Sahiblənmə» — mədəni	Kontekst və mədəni norma.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- SCID-D-R — strukturlaşdırılmış klinik müsahibənin yenidən işlənmiş variantıdır; qızıl standart hesab olunur.
- DES, MID şkalaları.
- C-SSRS intihar riski; özünəzərərvermənin qiymətləndirilməsi.
- EEQ tutma istisnası.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (ISSTD 2011)

1. Fazalı (mərhələyönümlü) üçmərhələli yanaşma:
    - Faza 1 — stabilizasiya və simptomların azaldılması: təhlükəsizlik, emosional tənzimləmə, öhdəsindən gəlmə (başa çıxma) bacarıqları, hospitalizasiyaların azaldılması, özünəzərərvermənin idarə edilməsi.

- Faza 2 — travmatik xatirələrin emalı: uyğunlaşdırılmış travma-fokuslu müdaxilə.
- Faza 3 — inteqrasiya və reabilitasiya: identifikasiyalar arası ünsiyyət, funksional bərpa, münasibətlər.

2. Spesifik psixoterapevtik yanaşmalar — Daxili Ailə Sistemləri (ing. Internal Family Systems, Schwartz R.) elementləri, uyğunlaşdırılmış EMDR (göz hərəkətləri ilə desensibilizasiya və yenidən emal).
3. Farmakoterapiya — DİP üçün xüsusi təsdiqlənmiş dərman yoxdur; komorbid PTSP, TDP, narahatlıq simptomları üçün SSGİ, prazosin (kabuslar).
4. Hospitalizasiya — kəskin özünəzərərvermə və ya intihar riskində.
5. Multidissiplinar yanaşma — psixiatr, psixoloq, sosial dəstək.
6. Uzunmüddətli müalicə (illər); həkim davamlılığı və terapevtik ittifaq həlledicidir.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Mərhələyönümlü müalicə (ing. Phase-Oriented Treatment — ISSTD) üç fazalı yanaşma; ardıcıllıq və pasiyent stabilliyi əsasdır.
2. Dissosiativ Pozuntular üçün Strukturlaşdırılmış Klinik Müsahibə (ing. Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders, Revised, SCID-D-R) — 277 maddəlik strukturlaşdırılmış müsahibə; qızıl standart.
3. Dissosiativ Təcrübələr Şkalası (ing. Dissociative Experiences Scale, DES) — 28 maddə; skrininq.
4. Çoxölçülü Dissosiasiya Sorğusu (ing. Multidimensional Inventory of Dissociation, MID) — 218 maddə; ətraflı dissosiativ profil.
5. EMDR modifikasiyası — stabilizasiyadan sonra travmanın emalı; ardıcıllığa və pasiyentin dayanıqlığına uyğunlaşdırılır.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- ISSTD 2011 — fazalı yanaşma qızıl standartdır.
- Travma-əsaslı yanaşma və iatrogenez ehtiyatı — «alters» axtarışı və ya induksiyasından qaçınma.

9. Proqnoz

- Uzunmüddətli fazalı terapiya ilə funksional bərpa.
- Yüksək intihar və özünəzərərvermə riski izlənir.
- Komorbidlik müalicəsi vacibdir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «DİP — kütləvi mediadakı kimi „şəxsiyyətin parçalanması“dir»

Sübut: film və ya televiziya təsvirləri (dramatik keçidlər, «fərqli insanlar») əksər pasiyentlərdə rast gəlinən daha incə klinik təzahürlərlə üst-üstə düşmür — daha çox «nəzarətin itməsi», daxili səslər və amneziyalar ön plandadır.

Mif 2: «DİP terapevt tərəfindən induksiya edilmiş yalandır»

Sübut: uşaqlıq travması ilə güclü əlaqə (Putnam icmalları); neyrobioloji markerlər (Reinders fMRT tədqiqatları); beynəlxalq tədqiqatlar ardıcıl nəticələr verir. Lakin diaqnostika ehtiyatlı olmalıdır — alter induksiya texnikalarından qaçınma vacibdir.

Mif 3: «DİP nadir və ya uydurma pozuntudur»

Sübut: klinik əhali qruplarında 1–3% yayılma (Sar 2011); diaqnozu isə çox vaxt qoyulmur.

Mif 4: «Hipnoz və ya hospitalizasiya əsas müalicədir»

Sübut: fazalı (mərhələyönümlü) psixoterapiya birinci sıra müalicədir; hipnoz əlavə metod kimi istifadə oluna bilər (ehtiyatla); hospitalizasiya yalnız kəskin özünəzərərvermə və ya intihar riskində.

Mif 5: «DİP-li pasiyent zorakılıq törətməyə meyllidir»

Sübut: DİP-li pasiyentlərdə zorakılıq qurbanı olma ehtimalı daha yüksəkdir; zorakılıq başqalarına qarşı nadirdir. «Şizofreniyalı insanlar təhlükəlidir» mifinin paralelidir.

Mif 6: «Bütün identifikasiyaları „birinə birləşdirmək“ əsas məqsəddir»

Sübut: inteqrasiya tipik məqsəddir, lakin bütün pasiyentlərdə tam birləşməyə nail olmaq mümkün deyil; «kooperasiya» və «funksional fəaliyyət» də klinik nəticə kimi qəbul edilir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşri» (XBT-11). 6B64 Dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşri, Mətn Yenilənməsi» (DSM-5-TR). 2022.
3. Beynəlxalq Travma və Dissosiasiya Tədqiqatı Cəmiyyəti (ISSTD). «Böyüklərdə Dissosiativ Şəxsiyyət Pozuntusunun Müalicəsi üzrə Təlimatlar,

Üçüncü Yenidən İşlənmə». «Travma və Dissosiasiya Jurnalı» (J Trauma Dissociation). 2011;12(2):115–187.

4. Sar V. Dissosiativ pozuntuların epidemiologiyası: ümumi icmal. «Beynəlxalq Epidemiologiya Tədqiqatları» (Epidemiology Research International). 2011;2011:404538.
5. Putnam F.V. Çoxşəxsiyyətlilik pozuntusunun diaqnostikası və müalicəsi. Nyu-York: Guilford Press; 1989.
6. Reynders A.A.T.S. və b. Autentik və simulyasiya edilmiş dissosiativ şəxsiyyət vəziyyətlərinin psixobioloqiyası: tam Monti. «Əsəb və Zehni Xəstəliklər Jurnalı» (J Nerv Ment Dis). 2016;204(6):445–457.
7. Staynberq M. DSM-IV Dissosiativ Pozuntuları üçün Strukturlaşdırılmış Klinik Müsahibə, Yenidən İşlənmiş (SCID-D-R). APA Press; 1994.
8. Lilienfeld S.O., Linn S.C., Kirs İ. və b. Dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu və sosiokoqnitiv model: keçmişin dərslərinin xatırlanması. «Psixoloji Bülleten» (Psychol Bull). 1999;125(5):507–523.
9. Şvarts R.C., Svisi M. Daxili Ailə Sistemləri Terapiyası. 2-ci nəşr. Nyu-York: Guilford Press, 2020.

XBT-11 **6B65**	**6B65 PARSİAL DİSSOSİATİV İDENTİFİKASİYA POZUNTUSU** **Partial dissociative identity disorder**
XBT-10 F44.8	Digər dissosiativ (konversiya) pozuntular
DSM-5-TR F44.89	Digər dəqiqləşdirilmiş dissosiativ pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Parsial Dissosiativ İdentifikasiya Pozuntusu (ing. XBT-11: 6B65 parsial dissosiativ identifikasiya pozuntusu; Partial Dissociative Identity Disorder) — DİP-ə (6B64) bənzər, lakin qeyri-dominant identifikasiyaların ardıcıl şəkildə pasiyentin davranışını və ya şüur funksiyasını tam tutmaması ilə fərqlənir. Bunun yerinə qeyri-dominant identifikasiyalar müdaxilə edir, lakin icraedici nəzarəti tam ələ keçirmir.

XBT-11-də ilk dəfə rəsmi diaqnostik kateqoriya kimi əlavə edilmişdir; DSM-5-TR-də ayrıca yoxdur (DSM-5-TR-də «digər dəqiqləşdirilmiş dissosiativ pozuntu» (Other Specified Dissociative Disorder) çərçivəsində qiymətləndirilə bilər).

2. Tarixçə

- XBT-11 (2019) — DİP-in spektrinin tanınması və parsial formanın rəsmi kateqoriya kimi müəyyən edilməsi.
- Klinik təcrübədə «başqa cür dəqiqləşdirilməmiş dissosiativ pozuntu» (DDNOS) kimi tanınan vəziyyətlərə yeni diaqnostik çərçivə təqdim olunur.

3. Epidemiologiya

- Yayılma haqqında dəqiq məlumat məhduddur — DİP-dən sıx olduğu güman edilir.
- Travma əsasında inkişaf edir.
- Komorbidlik DİP-də olduğu kimidir.

4. Etiologiya və patogenez

DİP ilə eynidir — uşaqlıq dövrünün ağır travması, dezorqanizə olunmuş bağlanma, neyrobioloji dissosiativ proseslər.

5. Klinik təzahürlər

- İki və ya daha çox fərqli identifikasiya vəziyyəti.
- Qeyri-dominant identifikasiyalar müdaxilə edir (daxili səslər, fikirlər, hisslər, hərəkətlər), lakin pasiyentin davranışını və şüurunu tam tutmur.
- Dominant identifikasiya gündəlik fəaliyyəti idarə edir.
- DİP ilə müqayisədə daha az amneziya müşahidə olunur.
- Əzab-əziyyət və funksional pozulma.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (XBT-11)

A. İki və ya daha çox fərqli identifikasiya vəziyyəti.

B. Qeyri-dominant identifikasiyalar dominant identifikasiyanın şüur və davranış nəzarətini ardıcıl şəkildə tam tutmur; lakin intruziv (intrusive) təcrübə kimi mövcuddur.

C. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

D. Maddə və ya tibbi vəziyyət istisnası.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 — DİP-dən «tam ələ keçirməmək» ilə fərqlənir.
- DSM-5-TR — «digər dəqiqləşdirilmiş dissosiativ pozuntu» (Other Specified Dissociative Disorder; F44.89) çərçivəsində qiymətləndirilə bilər.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

DİP ilə eyni (bax 6B64 §6.3).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
DİP (6B64)	Qeyri-dominant identifikasiyalar dominant nəzarəti ardıcıl ələ keçirir və amneziya müşahidə olunur.
PTSP / KPTSP (6B40/6B41)	Travmatik intruzivlər; ayrı identifikasiyalar yox.
ŞPP (6D10.x)	Emosional dəyişkənlik dominant.
Şizofreniya (6A20)	Psixotik simptomlar.
Possession trance (mədəni)	Mədəni və dini kontekst.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

DİP ilə eyni (SCID-D-R, DES, MID).

8. Müalicə

DİP üçün fazalı yanaşma uyğunlaşdırılır (ISSTD 2011). Müalicə prinsipləri, mərhələləri və konkret metodikaları üçün 6B64 «Müalicə» bölməsinə baxın (o cümlədən «Müalicə metodikaları»).

9. Proqnoz

Fazalı terapiya ilə funksional bərpa; DİP-ə bənzər.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Parsial DİP — DİP-in „yüngül forması“dır»

Sübut: ayrı diaqnostik kateqoriyadır; funksional pozulma və travma yükü DİP ilə müqayisəli ola bilər.

Mif 2: «Daxili səslər həmişə psixotik simptomdur»

Sübut: dissosiativ səslər psixotik simptomlardan fərqlənir — daxili dialoq, «öz» hissi ilə müşayiət olunması, antipsixotiklərə zəif cavab; SCID-D-R diferensiasiya üçün.

Mif 3: «Antipsixotiklər parsial DİP-də „səsləri“ aradan qaldırır»

Sübut: dissosiativ səslər antipsixotikə cavab vermir; psixoterapiya birinci sıra müalicədir.

Mif 4: «Pasiyent „rol oynayır“»

Sübut: süni pozuntu pozuntudan (6D50) fərqli — qazanc motivasiyası yox; klinik təcrübə pasiyent üçün əzabvericidir.

11. Mənbələr

1. ÜST. «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşri» (XBT-11). 6B65 Qismən dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu. 2024.
2. APA. «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşri, Mətn Yenilənməsi» (DSM-5-TR). 2022.
3. ISSTD. «Böyüklərdə Dissosiativ Şəxsiyyət Pozuntusunun Müalicəsi üzrə Təlimatlar, Üçüncü Yenidən İşlənmə». «Travma və Dissosiasiya Jurnalı» (J Trauma Dissociation). 2011;12(2):115–187.
4. Reynders A.A.T.S. və b. «Əsəb və Zehni Xəstəliklər Jurnalı» (J Nerv Ment Dis). 2016;204(6):445–457.

	6B66 DEPERSONALİZASİYA-DEREALİZASİYA POZUNTUSU
XBT-11 6B66	**Depersonalization-derealization disorder**
XBT-10 F48.1	Depersonalizasiya-derealizasiya sindromu
DSM-5-TR F48.1	Depersonalizasiya/derealizasiya pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Depersonalizasiya-Derealizasiya Pozuntusu (XBT-11: 6B66; DSM-5-TR: F48.1) — davamlı və ya təkrarlanan depersonalizasiya (özündən kənarda olmaq, bədəndən və düşüncələrdən qopma hissi) və/yaxud derealizasiya (ətrafın qeyri-real, «tutqun film kimi» görünməsi) ilə xarakterizə olunan dissosiativ pozuntudur. Reallığın qiymətləndirilməsi saxlanılır (pasiyent təcrübənin qeyri-real olduğunu bilir).

2. Tarixçə

- Krishaber M. (1873) — ilk təsvir.
- Dugas L. (1898) — «dépersonnalisation» termini.
- DSM-III (1980) — ayrı diaqnoz.
- DSM-5 (2013) — depersonalizasiya və derealizasiya birgə kateqoriya kimi.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 1–2% klinik formada; subklinik təcrübələr əhalinin 50%-ində ən azı bir dəfə müşahidə olunur.
- Cins: təxminən bərabər.
- Başlanğıc: yeniyetməlik və erkən yetkinlik (orta hesabla 16 yaş).
- Komorbidlik: TDP, panik, ÜTP, PTSP, ŞPP.

4. Etiologiya və patogenez

- Travma və stres tətikləyici (xüsusilə kannabis, hallüsinogen istifadəsi).
- Neyrobioloji — prefrontal-limbik tənzimləmənin pozulması; sensor emalı anomaliyaları (Simeon D. icmalları).
- Komorbid narahatlıq və panik tutmalarının tezliyi yüksəkdir.

5. Klinik təzahürlər

- Depersonalizasiya: özündən kənardan baxma hissi, robot kimi hiss etmə, emosional keyləşmə, «bədənim mənə aid deyil» hissi.
- Derealizasiya: ətrafın «tutqun film kimi» və ya «süni» görünməsi; məsafə qavrayışı dəyişikliyi.
- Reallığın qiymətləndirilməsi saxlanılır — pasiyent təcrübənin qeyri-real olduğunu bilir.
- Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və funksional pozulma.
- Tipik gediş — davamlı və ya təkrarlanan epizodlar.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Davamlı və ya təkrarlanan depersonalizasiya və/yaxud derealizasiya təcrübələri.

B. Reallığın qiymətləndirilməsi saxlanılır.

C. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

D. Maddə (kannabis, halüsinogen) və ya tibbi vəziyyət (tutma, beyin zədəsi) istisnası.

E. Başqa psixi pozuntu (panik tutması ərzində qısamüddətli; PTSP fonunda; şizofreniya) ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — eyni meyarlar.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Kembric Depersonalizasiya Şkalası (ing. Cambridge Depersonalisation Scale, Sierra M., Berrios G.E., CDS) 29 maddədən ibarətdir.
3. Tibbi və neyroloji müayinə (tutma, beyin zədəsi istisnası).

4. Toksikoloji skrininq.
5. Komorbidlik.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Panik atak	Atak kontekstində qısamüddətli.
PTSP (6B40)	Travma fonunda; intruzivlər.
DİP (6B64)	Fərqli identifikasiyalar.
Tutma (epileptik)	EEQ; postiktal vəziyyət.
Şizofreniya	Reallığın qiymətləndirilməsi pozulmuşdur.
Maddə induksiyalı (kannabis, LSD)	Toksikoloji.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- CDS qızıl standart hesab olunur.
- EEQ tutma istisnası varsa.
- Toksikoloji.

8. Müalicə

1. KDT (koqnitiv-davranış terapiyası) — depersonalizasiya üçün uyğunlaşdırılmış; koqnitiv yenidən strukturlaşdırma və ekspozisiya (məruz qalma). Hunter E.C. və b. Behav Res Ther 2005.
2. SSGİ (seçici serotonin geri alım inhibitorları) — komorbid depressiya və narahatlıqda effektivdir; pozuntunun özü üçün sübut bazası məhdud.
3. Lamotrigin adjunkt — bəzi tədqiqatlarda effekt.
4. Travma fonunda — travma-fokuslu yanaşma.
5. Kannabis və halüsinogen istifadəsindən imtina kritik.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Depersonalizasiya üçün KDT — Hanter (Hunter E.C.) və Sierra (Sierra M.) koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, ekspozisiya, torpaqlama (grounding) texnikaları.
2. Kembric Depersonalizasiya Şkalası (ing. Cambridge Depersonalisation Scale, CDS) — 29 maddə.

3. Torpaqlanma (grounding) texnikaları — 5-4-3-2-1 (5 görünən obyekt, 4 səs və s.); sensor diqqət.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Sierra M. icmallarına görə KDT və SSGİ əlavə metod kimi istifadə olunur.
- Spesifik FDA təsdiqli preparat yoxdur.

9. Proqnoz

- Gedişi xronikdir, lakin KDT ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma müşahidə olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Depersonalizasiya psixoz əlamətidir»

Sübut: reallığın qiymətləndirilməsi qorunur; psixotik pozuntudan fərqlidir; antipsixotiklər effektsizdir.

Mif 2: «Depersonalizasiya keçicidir, müalicə tələb etmir»

Sübut: klinik formada xronik gediş və funksional pozulma; müdaxilə tövsiyə olunur.

Mif 3: «Kannabis depersonalizasiyanı yaxşılaşdırır»

Sübut: kannabis tətikləyici və davam etdirici amildir; imtina kritik.

Mif 4: «Benzodiazepin əsas müalicədir»

Sübut: benzodiazepin qısamüddətli rahatlıq verir, lakin asılılıq və depersonalizasiyanın gücləndirilməsi riski mövcuddur.

Mif 5: «Yalnız antidepresanlar effektivdir»

Sübut: KDT birinci sıra; SSGİ komorbid simptomlarda.

11. Mənbələr

1. ÜST. «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşri» (XBT-11). 6B66 Depersonalizasiya-derealizasiya pozuntusu. 2024.
2. APA. «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşri, Mətn Yenilənməsi» (DSM-5-TR). 2022.
3. Syerra M. Depersonalizasiya: diqqətdən kənar qalmış sindroma yeni baxış. Kembric: Cambridge Univ Press; 2009.

4. Hanter E.C.M. və b. Depersonalizasiya pozuntusu üçün koqnitiv-davranış terapiyası: açıq tədqiqat. «Davranış Tədqiqatları və Terapiyası» (Behav Res Ther). 2005;43(9):1121–1130.
5. Simeon D. Depersonalizasiya pozuntusu: müasir icmal. «Mərkəzi Sinir Sistemi Dərmanları» (CNS Drugs). 2004;18(6):343–354.
6. Syerra M., Berrios C.E. Kembric Depersonalizasiya Şkalası: depersonalizasiyanın ölçülməsi üçün yeni alət. «Psixiatriya Tədqiqatları» (Psychiatry Res). 2000;93(2):153–164.

6B80–6B8Z Qida qəbulu pozuntuları (yemə pozuntuları)

Qidalanma və ya yemə pozuntuları (feeding or eating disorders)

XBT-11 **6B80**	**6B80 SİNİR ANOREKSİYASI** **Anorexia Nervosa**
XBT-10 F50.0	Anoreksiya nervoza
DSM-5-TR F50.0x	Anoreksiya nervoza

1. Tərif və nozologiya

Anoreksiya nervoza (XBT-11: 6B80; DSM-5-TR: F50.0x) — qida qəbulunun məhdudlaşdırılması nəticəsində əhəmiyyətli aşağı bədən çəkisi, çəki artımından kəskin qorxu və bədən obrazının pozulması ilə xarakterizə olunan ağır yemə pozuntusudur. Mortalite psixiatrik pozuntular arasında ən yüksəkdir.

2. Tarixçə

- Morton R. (1689) — ilk klinik təsvir.
- Lasègue C. (1873) və Gull W. (1874) — «anorexia hysterica» və «Anoreksiya nervoza».
- DSM-III (1980) — rəsmi diaqnoz.
- DSM-5 (2013) — amenoreya meyarı ləğv edilmişdir (kişilərdə və menarxedən əvvəlki dövrdə də diaqnoz mümkündür).

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: qadınlarda 0,9–4%, kişilərdə 0,3% (Smink F.R. icmalları).
- Cins: qadınlarda 10:1; lakin kişi pasiyentlərdə diaqnoz çox vaxt qoyulmur.
- Başlanğıc: yeniyetməlik (14–18 yaş); ikinci zirvə orta yaş dövrünə təsadüf edir.

- Mortalite: ömürlük 5–6%; yarısı tibbi səbəblərdən (kaxeksiya, ürək çatışmazlığı), yarısı intihardan (Arcelus J. və b. Arch Gen Psychiatry 2011 meta-analiz).
- Komorbidlik: TDP, OKP, narahatlıq, ŞPP.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsi meyillilik 50–60%-dir (Bulik C.M. icmalları).
- Neyrobioloji — koqnitiv elastikliyin azalması, mükafat sisteminin derequlyasiyası, aclığa qeyri-tipik cavab.
- Sosial-mədəni amillər — incəlik idealı; sosial şəbəkələrin təsiri.
- Şəxsiyyət — mükəmməllikçilik, narahatlıq, ailə tarixçəsində yemə pozuntusu.

5. Klinik təzahürlər

- Qida məhdudlaşdırılması — kalori, qida növləri.
- Bədən çəkisi əhəmiyyətli aşağı (bədən kütlə indeksi — BKİ < 18,5 yetkinlərdə; uşaqlarda BKİ persentili).
- Çəki artımından kəskin qorxu və ya qarşısının alınmasına yönəlmiş davamlı davranış.
- Bədən imajının pozulması — «kök hiss edirəm» arıq olduqda da.
- Alt-tiplər:
    - Məhdudlaşdırıcı tip — yalnız qida məhdudlaşdırılması.
    - Obur yemə/təmizlənmə tipi — qusma, laksativ, idman.
- Tibbi komplikasiyalar — bradikardiya, hipotenziya, hipotermiya, elektrolit balanssızlığı, osteoporoz, amenoreya, lanugo, ürək aritmiyası, ölüm.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Qida qəbulunun məhdudlaşdırılması nəticəsində əhəmiyyətli aşağı çəki (BKİ < 18,5 yetkinlərdə; uşaqlarda yaşa uyğun normadan aşağı).

B. Çəki artımından kəskin qorxu və ya buna qarşı davamlı davranış, çəki aşağı olsa belə.

C. Bədən imajının pozulması və ya hazırkı çəkinin ciddiyyətini dərk etməmə.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — şiddət BKİ əsasında (yüngül BKİ ≥ 17, orta 16–16,99, ağır 15 –15,99, ekstremal < 15).
- XBT-11 — fərqli şiddət şkalası: 6B80.0 əhəmiyyətli dərəcədə aşağı bədən çəkisi (yetkinlərdə BKİ 14,0–18,5; uşaqlarda yaşa görə BKİ 0,3–5-ci persentil), 6B80.1 təhlükəli dərəcədə aşağı bədən çəkisi (BKİ < 14,0), 6B80.2 normal çəki ilə sağalma dövrü — diaqnoz tam və davamlı sağalmaya qədər saxlanılır. XBT-11-də ayrıca «atipik Anoreksiya nervoza» kateqoriyası yoxdur (ing. termin DSM-5-TR-in OSFED-inə aiddir): normal BKİ ilə hal 6B80.2-dir, meyarlar yerinə yetirilmirsə 6B8Y — digər dəqiqləşdirilmiş qidalanma və ya yemə pozuntuları.
- NICE NG69 (Eating disorders, 2017, yenilənmə) — diaqnoz və müalicə alqoritmləri.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Yemə pozuntusu müayinə sorğusu (ing. EDE-Q, Eating Disorder Examination Questionnaire) və ya EDE — qızıl standart.
3. Tibbi müayinə — BKİ, həyati göstəricilər, elektrolitlər, EKG, sümük dansitometriyası.
4. Laborator: tam qan, elektrolitlər (xüsusilə K, P, Mg), qaraciyər, böyrək, qlükoza, tiroid.
5. Komorbidlik (TDP, OKP, narahatlıq).
6. Yenidən qidalandırma sindromu (ing. refeeding syndrome) riskinin qiymətləndirilməsi (xüsusilə BKİ < 13 və ya minimal qida qəbulu uzun müddət).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Bulimiya nervoza (6B81)	Normal çəki; həddindən artıq yemə və təmizləyici davranış.
QYQTP (6B83)	Çəki itkisi, lakin bədən imajı pozulması yoxdur.
Tibbi xəstəlik (xərçəng, hipertiroidizm, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu — IBS, Crohn xəstəliyi)	Klinik təsdiq.

Vəziyyət	Fərqləndirici
TDP (qida qəbulunun azalması)	Bədən imajı pozulması yoxdur.
Şizofreniya (qida sayıqlaması)	Psixotik fikir əsas.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- EDE-Q, EDE.
- Vital göstəricilər, BKİ, çəki tarixçəsi.
- Laborator: tam qan, elektrolitlər, qaraciyər, böyrək, tiroid, FSH/LH, prolaktin, vitamin D, B12, dəmir.
- EKG — bradikardiya, QTc.
- DEXA — osteoporoz.
- C-SSRS intihar riski.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE NG69, APA 2023)

1. Tibbi stabilizasiya həlledicidir: elektrolitlər, refeeding sindromu profilaktikası (fosfor, magnezium, tiamin), kardial monitorinq.
2. Hospitalizasiya göstərişləri: BKİ < 13, bradikardiya < 40 vuruş/dəq, hipokalemia, ortostatik dəyişikliklər, intihar (suisid) riski, ambulator şəraitdə uğursuzluq.
3. Birinci sıra müalicə — psixoterapiya:
    - FBT — ailə əsaslı müalicə (ing. Family-Based Treatment; Maudsley modeli, Lock J., Le Grange D.) qızıl standart sayılır — uşaq və yeniyetmələrdə qızıl standart; 3 fazada 20 seans.
    - KDT-E — Gücləndirilmiş koqnitiv-davranış terapiyası (ing. Enhanced Cognitive Behavioral Therapy) (Fairburn C.G.) — yetkinlərdə birinci sıra; 40 seans 40 həftə.
    - MANTRA, SSCM yetkin alternativləri.
4. Farmakoterapiya SA (sinir anoreksiyası) üçün spetsifik effektiv preparat yoxdur — antidepresan və antipsixotik komorbidlik üçün; olanzapin aşağı dozada (2,5–10 mq) bəzi pasiyentlərdə çəki artımına yardım edə bilər (Attia E. və b. Am J Psychiatry 2019), lakin əsas müdaxilə deyil.
5. Qidalanma dəstəyi — qrup və ya fərdi dietoloqla; refeeding sindromu profilaktikası — başlanğıc enerji miqdarı aşağı səviyyədən artırılır, fosfor monitorinqi.

6. Müalicə müddəti uzundur (1–2 il və ya daha çox).

8.2 Müalicə metodikaları

1. Ailə-Əsaslı Müalicə / Maudsli Modeli (FBT — Ailə əsaslı müalicə (ing. Family-Based Treatment)) — Lok (Lock J.), Le Qranj (Le Grange D.) — 3 fazalı 20 seans: (1) çəkinin bərpası — ailə qida qəbulunu nəzarət edir; (2) yemə nəzarətinin tədricən yeniyetməyə qaytarılması; (3) yeniyetmə-spesifik mövzular. Sübut: Lock J. və b. Arch Gen Psychiatry 2010 RKİ.
2. Gücləndirilmiş Koqnitiv-Davranış Terapiyası (ing. Enhanced Cognitive Behavioral Therapy, CBT-E) — Feyrbörn (Fairburn C.G.) — Transdiaqnostik yanaşma (sinir anoreksiyası, sinir bulimiyası, həddindən artıq yemə pozuntusu birlikdə); 40 seans 40 həftə; mərkəzdə bədən və çəki haqqında həddən artıq dəyər. cbte.co.
3. Maudsley modeli üzrə yetkinlərdə sinir anoreksiyasının müalicəsi (ing. Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults, MANTRA) — Şmidt (Schmidt U.) — Yetkinlər üçün manualizə edilmiş; sosial-mükəmməllikçi xüsusiyyətlərə yönəlmişdir.
4. Mütəxəssis Dəstəkləyici klinik dəstək müalicəsi (ing. Specialist Supportive Clinical Management, SSCM) — Klinik nəzarət və psixoedukasiya əsaslı.
5. Yemə pozuntusu müayinə sorğusu (ing. Eating Disorder Examination Questionnaire, EDE-Q) — 28 maddə; ilkin göstəricilər və izləmə.
6. Yenidən qidalandırma protokolu (Maudsley, AED) — Riskə görə başlanğıc: yüksək riskdə 10 kkal/kq/gün, çox yüksək riskdə (BKİ < 14 və ya 15 gündən çox təcrübədə qida qəbulu yoxdur) 5 kkal/kq/gün; artım tədricən. Fosfor, magnezium, kalium əlavələri; tiamin; gündəlik elektrolit monitorinqi. Daha yüksək sürət yalnız ixtisaslaşmış şöbədə, sıx nəzarət altında.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG69 (2017) — FBT uşaq və yeniyetmələrdə; KDT-E yetkinlərdə.
- APA 2023 Practice Guideline for the Treatment of Patients with Eating Disorders, 4th ed.
- AED (ing. Academy for Eating Disorders) — refeeding sindromunda tibbi qayğı standartları.
- NICE — SA üçün antidepresanlar rutin qaydada tövsiyə edilmir.

9. Proqnoz

- 50% remissiya, 30% qalıq simptomlar, 20% xronik gediş.
- Mortalite yüksəkdir (5–6%).

- Erkən müdaxilə (xüsusilə yeniyetməlikdə FBT) proqnozu əhəmiyyətli yaxşılaşdırır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Anoreksiya „bədən obrazı“ pozuntusudur, ciddi tibbi vəziyyət deyil»

Sübut: Arcelus 2011 meta-analiz — AN ömürlük mortalitet 5–6%; psixiatrik pozuntular arasında ən yüksək.

Mif 2: «Pasiyent iradi olaraq yeyə bilər — sadəcə tələb etmək lazımdır»

Sübut: AN neyrobioloji və psixoloji mürəkkəb pozuntudur; «iradi olaraq yemə» izahatı yanlış və zərərli.

Mif 3: «Antidepressant AN-da əsas müalicədir»

Sübut: NICE NG69 — AN üçün antidepressant rutin tövsiyə edilmir; komorbid TDP üçün istifadə oluna bilər (çəki bərpasından sonra daha təsirlidir).

Mif 4: «AN yalnız yeniyetmə qızlarda olur»

Sübut: AN kişilərdə də mövcuddur (təxminən 10%); orta yaşda da inkişaf edə bilər; diaqnozun nadir qoyulması tez-tez müşahidə olunur.

Mif 5: «Çəki bərpasından sonra problem həll olunur»

Sübut: çəki bərpası vacib addımdır, lakin koqnitiv-davranış komponentinə müdaxilə olmadan residiv riski yüksəkdir; psixoterapiya kritik.

Mif 6: «Refeeding sürətli olmalıdır»

Sübut: sürətli refeeding sindromuna (hipofosfatemiya, kardial çatışmazlıq) gətirə bilər; pilləli yanaşma və elektrolit monitorinqi kritik.

Mif 7: «Pasiyent perfeksionist və yüksək performanslıdır — bu xüsusiyyət saxlanılmalıdır»

Sübut: perfeksionizm AN-ın saxlayıcı amillərindəndir; terapiya bu xüsusiyyətə yönəlir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B80 Sinir anoreksiyası. 2024.

2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG69. Yemə pozuntuları: tanınma və müalicə. 2017, 2020-ci il yenilənməsi.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Yemə pozuntuları olan xəstələrin müalicəsi üzrə praktiki təlimat, 4-cü nəşr. 2023.
5. Lok C., Le Qranj D., Aqras V.S. və b. Anoreksiya nervozası olan yeniyetmələrdə ailəyə əsaslanan müalicənin yeniyetməyə yönəlmiş fərdi terapiya ilə müqayisəsi üzrə randomizə edilmiş klinik sınaq. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2010;67(10):1025–1032.
6. Feyrbern C.Q. Koqnitiv davranış terapiyası və yemə pozuntuları. Qilford Nəşriyyatı; 2008.
7. Arselus C., Mitçell A.C., Veylz C., Nilsen S. Anoreksiya nervoza və digər yemə pozuntuları olan xəstələrdə ölüm göstəriciləri: meta-analiz. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2011;68(7):724–731.
8. Attia E. və b. Anoreksiya nervozası olan ambulator böyüklərdə olanzapinin plasebo ilə müqayisəsi. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2019;176(6):449–456.
9. Smink F.R. van Huken D., Huk H.V. Yemə pozuntularının epidemiyologiyası. «Müasir Psixiatriya Hesabatları» (Curr Psychiatry Rep). 2012;14(4):406–414.
10. Lok C., Le Qranj D. Anoreksiya nervozanın müalicəsi üzrə təlimat: ailəyə əsaslanan yanaşma. 2-ci nəşr. Nyu-York: Qilford Nəşriyyatı; 2013.
11. Şmidt U., Trejur C. Anoreksiya nervoza: dəyərli və görünən. Koqnitiv-interpersonal davamlılıq modeli. «Britaniya Klinik Psixologiya Jurnalı» (Br J Clin Psychol). 2006;45(3):343–366.
12. Bulik C.M., Sullivan P.F., Tozzi F. və b. Anoreksiya nervozanın yayılması, irsiyyət payı və prospektiv risk faktorları. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2006;63(3):305–312.

XBT-11 **6B81**	**6B81 SİNİR BULİMİYASI** **Bulimia Nervosa**
XBT-10 F50.2	Bulimiya nervoza
DSM-5-TR F50.2	Sinir bulimiyası (bulimia nervosa)

1. Tərif və nozologiya

Bulimiya nervoza (XBT-11: 6B81; DSM-5-TR: F50.2) — təkrarlanan obur yemə epizodları (qısa müddətdə çoxlu qida qəbulu və nəzarət itkisi hissi) və kompensator davranışlar (qusma, laksativ, idman, oruc) ilə xarakterizə olunan yemə pozuntusudur. Anoreksiya nervozadan fərqli olaraq çəki adətən normal və ya artıq olur.

2. Tarixçə

- Russell G.F. (1979) — «bulimiya nervoza» (bulimia nervosa) termini və ilk klinik təsvir.
- DSM-III-də (1980) bu pozuntu rəsmi diaqnoz kimi qəbul edilmişdir.
- DSM-5 (2013) — tezlik meyarı həftədə 1 dəfəyə endirilmişdir (DSM-IV-də 2 dəfə).

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: qadınlarda 1,5–3%, kişilərdə 0,5%.
- Başlanğıc: yeniyetməlik və erkən yetkinlik.
- Komorbidlik: TDP təxminən 70%, narahatlıq, maddə istifadəsi, ŞPP, anorexia tarixçəsi.
- İntihar riski yüksəkdir.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 50–60%.
- Neyrobioloji — serotoninergik dizrequlyasiya, dopamin mükafat sistemi.
- Sosial-mədəni — incəlik idealı, pəhriz tarixçəsi.
- Şəxsiyyət — impulsivlik, perfeksionizm, aşağı özünə hörmət.

5. Klinik təzahürlər

Obur yemə epizodları — nəzarət itkisi hissi və gizli yemə ilə xarakterizə olunur.

Kompensator davranışlar:

- Təmizləyici davranış (ing. purging) — özünü qusdurma, laksativ və diuretiklərin istifadəsi;
- Təmizləyici olmayan davranış (ing. non-purging) — oruc və həddindən artıq idman.

Bədən obrazı və çəki ilə bağlı həddindən artıq məşğul olma.

Tibbi komplikasiyalar: hipokalemiya (qusma), Russell əlaməti (barmaqlarda döyənəklər), diş eroziyası, parotid vəzinin hipertrofiyası, ezofagit, mədə-bağırsaq pozuntuları.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Təkrarlanan obur yemə epizodlar — qısa müddətdə (≤ 2 saat) çoxlu qida + nəzarət itkisi hissi.

B. Çəki artımının qarşısını almaq üçün təkrarlanan qeyri-uyğun kompensator davranışlar.

C. Tezlik: ən azı həftədə 1 dəfə — DSM-5-TR ən azı 3 ay, XBT-11 isə ən azı 1 ay müddət tələb edir.

D. Özünə hörmət çəkidən və bədən formasından həddindən artıq asılıdır.

E. Anoreksiya nervoza epizodu kontekstində baş vermir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — şiddət epizodların tezliyinə görə (yüngül 1–3, orta 4–7, ağır 8–13, ekstremal — həftədə ≥ 14).
- XBT-11 — meyarlar üst-üstə düşür, lakin müddət fərqlidir: XBT-11 ən azı 1 ay, DSM-5-TR 3 ay tələb edir; Atipik bulimiya nervoza (atypical bulimia nervosa) XBT-11-də 6B81.Y alt kateqoriyası kimi verilir.
- NICE NG69 — diaqnoz və müalicə.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. EDE-Q, EDE.
3. Tibbi: elektrolitlər (kalium, fosfor, maqnezium, xlor), qaraciyər və böyrək funksiyası, EKG (QTc intervalı).
4. Diş müayinəsi (eroziya).
5. Komorbidlik və intihar riski qiymətləndirilir.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Anoreksiya nervoza, obur yemə/təmizlənmə tipi (6B80)	Çəki əhəmiyyətli aşağı.
BED (6B82)	Kompensator davranış yox.
Night Eating Syndrome	Gecə qida qəbulu üstündür.
Kleine-Levin sindromu	Hipersomniya və hiperfagiya.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- EDE-Q.
- Tibbi: elektrolitlər, EKG, diş müayinəsi.
- C-SSRS.

8. Müalicə

1. KDT-E birinci sıra (Fairburn) — 20 seans 20 həftə; sübut: Fairburn C.G. və b. Am J Psychiatry 2009;166(3):311–319.
2. Fluoksetin 60 mq/gün — FDA təsdiqi BN üçün; obur yemə və qusma azaldır.
3. Ailə əsaslı müalicə (FBT) — yeniyetmələrdə tətbiq edilir.
4. İPT alternativ.
5. Tibbi: elektrolit korreksiyası, yenidən qidalandırma (refeeding), dişlərə qulluq.
6. Bupropion əks göstərişdir (qıcolma riski).

8.1 Müalicə metodları

1. KDT-E (Fairburn) — 20 seans; diaqnozlararası; obur yemə-təmizlənmə zəncirinin qırılması.
2. Ailə əsaslı müalicə (FBT) bulimiya nervoza üçün yeniyetmələrə uyğunlaşdırılmışdır.
3. Şəxslərarası Terapiya (İPT / IPT — Interpersonal Therapy) — alternativ üsuldur; cavab gecikir, lakin effekt uzunmüddətli olur.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG69 — KDT-E birinci sıra; FBT yeniyetmələrdə.

- APA 2023.

9. Proqnoz

- 50–70% remissiya KDT-E ilə; uzunmüddətli izləmə vacib.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Bulimiya „pəhriz uğursuzluğu“dur»

Sübut: klinik pozuntudur; məhdudlaşdırıcı pəhriz tipik tətikləyicidir.

Mif 2: «Qusma çəki azaltma metodudur»

Sübut: qusma kalorilərin udulmasının yalnız 30–50%-nin qarşısını alır; ciddi tibbi komplikasiyalara səbəb olur.

Mif 3: «Bupropion bulimiya nervozada antidepresan kimi istifadə oluna bilər»

Sübut: bupropion BN-da əks-göstərişdir — tutma riski yüksək.

Mif 4: «Bulimiya nervozada normal çəki olduqda da problem yoxdur»

Sübut: tibbi komplikasiyalar (elektrolit, kardial) və psixiatrik yük əhəmiyyətlidir.

Mif 5: «Yalnız antidepresan kifayətdir»

Sübut: KDT-E + farmakoterapiya kombinasiyası üstün.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B81 Sinir bulimiyası. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG69. 2017/2020.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Yemə pozuntuları üzrə praktiki təlimat, 4-cü nəşr. 2023.
5. Feyrbern C.Q. Koqnitiv davranış terapiyası və yemə pozuntuları. Qilford Nəşriyyatı; 2008.
6. Rassel Q. Bulimiya nervoza: anoreksiya nervozanın təhlükəli variantı. «Psixoloji Tibb» (Psychol Med). 1979;9(3):429–448.

7. Lok C., Le Qranj D. Anoreksiya nervozanın müaliceəsi üzrə təlimat: ailəyə əsaslanan yanaşma. 2-ci nəşr. Nyu-York: Qilford Nəşriyyatı; 2013.

XBT-11 **6B82**	**6B82 AŞIRI QİDALANMA POZUNTUSU** **Binge eating disorder**
XBT-10 F50.8	Qida qəbulunun digər pozuntuları
DSM-5-TR F50.81	Obur yemə pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Aşırı qidalanma pozuntusu (XBT-11: 6B82; DSM-5-TR: F50.81) — təkrarlanan obur yemə epizodları (qısa müddətdə çoxlu qida + nəzarət itkisi hissi) ilə xarakterizə olunur, kompensator davranışlar isə müşahidə edilmir. Tipik olaraq çəki artıqdır və piylənmə ilə müşayiət olunur.

2. Tarixçə

- Stunkard A.J. (1959) — piylənmə kontekstində obur yemə təsviri.
- DSM-IV-də (1994) bu pozuntu tədqiqat kateqoriyası kimi verilmişdir.
- DSM-5 (2013) — ayrı rəsmi diaqnoz.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 1,9–3,5%; yemə pozuntuları arasında ən çox rast gəlinəndir.
- Cins nisbəti: qadın/kişi ≈ 1,5–2:1; kişilərdə də əhəmiyyətli dərəcədə rast gəlinir.
- Piylənmə ilə güclü əlaqə.
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, ŞPP, maddə istifadəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 40–50%.
- Neyrobioloji — mükafat dövrəsinin dizrequlyasiyası; «qida asılılığı» hipotezi.

- Emosional yemə — stres tətikləyicisidir.
- Məhdudlaşdırıcı pəhriz tarixçəsi.

5. Klinik təzahürlər

- Obur yemə epizodları — qısa müddətdə çoxlu qida qəbulu və nəzarət itkisi.
- Tipik xüsusiyyətlər: sürətli yemə, fiziki narahatlıq yaranana qədər yemə, gizli yemə, sonrakı utanc, sıxıntı.
- Kompensator davranış yox.
- Çəki artımı və piylənmə komplikasiyaları (Tip 2 diabet, kardiovaskulyar, YAPP).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Təkrarlanan obur yemə epizodlar.

B. Epizodlar aşağıdakılardan ən azı üçü ilə əlaqəlidir:

1. Sürətli yemə;
2. Fiziki tox olana qədər yemə;
3. Aclıq olmadan çoxlu yemə;
4. Gizlin yemə (utancdan);
5. Sonradan özündən iyrənmə, depressiv əhval və ya güclü günahkarlıq hissi.

C. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət.

D. Tezlik: həftədə ən azı 1 dəfə, ən azı 3 ay ərzində.

E. Sinir bulimiyası və ya anoreksiya nervoza kontekstində baş vermir; kompensator davranışlar yoxdur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — şiddət epizod tezliyinə görə.
- XBT-11 — şiddət şkalası yoxdur: DSM-5-TR epizodların tezliyinə görə dərəcə verir (yüngül 1–3, orta 4–7, ağır 8–13, ekstremal — həftədə ≥ 14), XBT-11 isə yalnız «həftədə bir dəfə və ya daha çox, bir neçə ay ərzində» ifadəsini müəyyən edir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.

2. EDE-Q.
3. Tibbi qiymətləndirmə — metabolik sindromun skrininqi (qlükoza, HbA1c, lipid profili, qan təzyiqi).
4. Komorbidlik.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Bulimiya (6B81)	Kompensator davranış.
Piylənmə (kompulsiv yemə olmadan)	Obur yemə epizodlarının xarakterik xüsusiyyətləri yoxdur.
Kleine-Levin	Kleine-Levin sindromu — hiperfagiya və hipersomniya.
Prader-Willi sindromu	Genetik; nəzarətdən çıxmış hiperfagiya.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- EDE-Q.
- Bədən kütləsi indeksi (BKİ), çəki, həyati göstəricilər.
- Metabolik panel.

8. Müalicə

1. KDT-E birinci sıra — BED-də əhəmiyyətli effekt; Wilson G.T. və b. icmalları.
2. Lizdeksamfetamin (Vyvanse) 30 mq/gün dozasından başlayaraq 50–70 mq/günə qədər titrlənir — obur yemə pozuntusu üçün FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir; obur yemə tezliyini əhəmiyyətli azaldır (McElroy S.L. JAMA Psychiatry 2015).
3. SSGİ — komorbid TDP üçün; obur yemə tezliyinə zəif effekt.
4. İPT alternativ.
5. Çəki idarəsi — pəhriz və fiziki aktivlik; çəki itkisi yemə pozuntusu üzrə müdaxilə olmadan effektli olmur.
6. Bariatrik cərrahiyə — uzunmüddətli izləmə tələb olunur (BED üzrə əməliyyatdan əvvəlki qiymətləndirmə).

8.1 Müalicə metodikaları

1. KDT-E BED üçün — Obur yemə zəncirinin qırılması, alternativ öhdəsindən gəlmə (başa çıxma) üsulları.
2. Lisdeksamfetamin — FDA təsdiqi BED üçün; başlanğıc 30 mq, hədəf 50–70 mq/gün.
3. İPT — Şəxslərarası məsələlərə fokus.
4. Rəhbərlik altında Özünəyardım KDT (ing. Guided Self-Help) — İnternet əsaslı, kitab əsaslı.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG69 — KDT və ya rəhbərlik altında özünəyardım birinci sıra müalicədir.
- APA 2023.
- Makelroyun lizdeksamfetamin üzrə randomizə edilmiş klinik tədqiqatları (RKİ).

9. Proqnoz

- KDT-E ilə 50–60% remissiya.
- Çəki idarəsi və metabolik komplikasiyalar uzunmüddətli izləmə tələb edir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Obur yemə pozuntusu sadəcə piylənmə və ya „çoxlu yemə“ şəxsiyyət xüsusiyyətidir»

Sübut: klinik yemə pozuntusudur; çoxlu yemə hadisəsindən fərqli xüsusiyyətlər (nəzarət itkisi, utanc hissi ilə yemə).

Mif 2: «Məhdudlaşdırıcı pəhriz BED-i sağaldır»

Sübut: məhdudlaşdırıcı pəhriz BED-in tətikləyicisidir — psixoloji müdaxilə olmadan çəki idarəsi obur yemə epizodlarını artırır.

Mif 3: «Bariatrik cərrahiyə BED-i sağaldır»

Sübut: cərrahiyə mədənin tutumunu azaldır, lakin koqnitiv-davranış komponenti dəyişdirməz; bəzi pasiyentdə bəzi pasiyentlərdə «arabir yemə» (grazing) yeni davranış modeli kimi formalaşır.

Mif 4: «Yemə asılılığı (qida asılılığı) narkotik asılılığı kimi müalicə edilməlidir»

Sübut: «qida asılılığı» konsepsiyadır, lakin klinik diaqnoz kimi qəbul edilməyib; standart yemə pozuntusu müdaxilələri üstündür.

Mif 5: «Obur yemə pozuntusu yalnız antidepresan tələb edir»

Sübut: lizdeksamfetamin obur yemə pozuntusu üçün ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA) tərəfindən təsdiqlənmişdir; KDT birinci sıra müalicədir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B82 Həddindən artıq yemə pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG69. 2017/2020.
4. MakElroy S.L. və b. Orta və ağır dərəcəli həddindən artıq yemə pozuntusu olan böyüklərin müalicəsində lisdeksamfetaminin effektivliyi və təhlükəsizliyi. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2015;72(3):235–246.
5. Vilson Q.T., Vilfley D.E., Aqras V.S., Brajson S.V. Həddindən artıq yemə pozuntusunun psixoloji müalicə üsulları. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2010;67(1):94–101.

	6B83 QAÇINAN-MƏHDUDLAŞDIRICI QİDA QƏBULU POZUNTUSU
XBT-11 **6B83**	**Avoidant-restrictive food intake disorder**
XBT-10 F98.2	Körpəlik və uşaqlıq dövrünün qidalanma pozuntusu
DSM-5-TR F50.82	Qaçınan/məhdudlaşdırıcı qida qəbulu pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Qaçınan/məhdudlaşdırıcı qida qəbulu pozuntusu (QYQTP; XBT-11: 6B83; DSM-5-TR: F50.82) — qida qəbulundan qaçınma və ya məhdudlaşdırma nəticəsində əhəmiyyətli çəki itkisi, qidalanma çatışmazlığı, enteral qidalanmaya və ya qida əlavələrinə ehtiyac, yaxud psixososial pozulma ilə nəticələnir. Bədən obrazının pozulması və ya çəki artımından qorxu yoxdur (anoreksiyadan əsas fərqi).

2. Tarixçə

- DSM-IV-də «körpəlik və uşaqlıq dövrünün qidalanma pozuntusu» — yalnız uşaqlarda diaqnoz qoyulurdu.
- DSM-5 (2013) — QYQTP bütün yaşlara genişləndirilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: 0,3–3,2% (yemə pozuntusu klinikalarında təxminən 5–14%).
- Cins nisbəti: təxminən bərabərdir (anoreksiya nervozadan fərqli olaraq).
- Başlanğıc: uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü üstünlük təşkil edir.
- Komorbidlik: autizm spektri pozuntusu, narahatlıq pozuntuları, obsesif-kompulsiv pozuntu (OKP).

4. Etiologiya və patogenez

- Sensor həssaslıq (qida teksturası, qoxu, görünüş) — xüsusilə autizm fonunda.
- Boğulma və ya qusma travmasından qorxu.
- Qidaya aşağı maraq (low appetite, low food interest).

5. Klinik təzahürlər

Üç klinik təzahür

- Sensor həssaslıq — seçici yemə (ing. picky eater) — məhdud qida növləri, teksturaya həssaslıq.
- Qidaya aşağı maraq — aclıq hissi azdır, qidaya stimul yoxdur.
- Qorxu (boğulma, qusma) — müəyyən tətikləyici hadisədən sonra yaranan qaçınma.

Nəticələr: əhəmiyyətli çəki itkisi və ya kifayət qədər çəki artımı olmaması (uşaqlarda), qidalanma çatışmazlıqları (dəmir, sink, vitamin), enteral qidalanma asılılığı, psixososial pozulma (məktəb naharı, yoldaşlarla birlikdə yemək).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Qida qəbulundan qaçınma və ya məhdudlaşdırma nəticəsində ən azı biri:

1. Əhəmiyyətli çəki itkisi və ya kifayət qədər çəki artımı olmaması;
2. Əhəmiyyətli qidalanma çatışmazlığı;
3. Enteral qidalanma və ya oral qidalanma əlavələrindən asılılıq;
4. Əhəmiyyətli psixososial pozulma.

B. Pozuntu mövcud qida çatışmazlığı ilə və ya mədəni təcrübə ilə izah olunmur.

C. Anoreksiya və ya bulimiya kontekstində baş vermir; bədən obrazının pozulması yoxdur.

D. Başqa tibbi və ya psixi vəziyyət (məs. allergiya, OKP) ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — eyni.
- NICE NG69 — QYQTP üçün xüsusi müdaxilə qaydaları.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və qida tarixçəsi.
2. NIAS (ing. Nine Item Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder Screen) — skrininq.
3. Tibbi qiymətləndirmə — çəki, boy, bədən kütləsi indeksi (BKİ), qidalanma çatışmazlığı üzrə laborator müayinələr.
4. Autizm və OKP skrininq.
5. Allergiya və qastrointestinal patologiyanın istisnası.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Anoreksiya (6B80)	Bədən obrazının pozulması və çəki qorxusu əsasdır.
Autizm spektri (6A02)	Sensor həssaslıq komponenti; QYQTP ASP ilə komorbid ola bilər.

Vəziyyət	Fərqləndirici
OKP (6B20)	Çirklənmə obsessiyaları əsas; kompulsiv ritual davranış.
Spesifik fobiya (6B03)	Konkret obyekt; QYQTP-də çoxsaylı qida növləri.
Allergiya / Kron xəstəliyi / çölyak xəstəliyi	Tibbi təsdiq.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- NIAS, EDE-Q.
- Çəki, boy və BKİ tarixçəsi.
- Laborator: tam qan, ferritin, sink, vitamin D, B12, folat.
- Autizm skrininq (M-CHAT, ADOS).

8. Müalicə

1. Multidissiplinar yanaşma: diyetoloq + KDT terapevti + məşğuliyyət terapevti.
2. FBT-QYQTP — Lock J. tərəfindən uyğunlaşdırılmış.
3. KDT-AR — Cognitive Behavioral Therapy for QYQTP (Thomas J.J.) — protokol şəklində standartlaşdırılmış.
4. Pilləli qida ekspozisiyası — yeni qida növlərinin tədricən tətbiqi.
5. Sensor inteqrasiya elementləri (autizm fonunda).
6. Tibbi: qidalanma ilə bağlı düzəliş; ağır hallarda enteral qidalanma tətbiq edilir.
7. Komorbid narahatlıq üçün SSGİ; spesifik FDA təsdiqli QYQTP üçün preparat yox.

8.1 Müalicə metodikaları

1. QYQTP üçün KDT (ing. CBT for ARFID, CBT-AR) — Tomas C.C. tərəfindən — Manualizə edilmiş; sensor həssaslıq, qidaya maraq azlığı və qorxu alt-tiplərinə uyğun protokollar.
2. FBT-QYQTP — Ailənin qida ekspozisiyasındakı roluna diqqət yetirilir.
3. Pilləli Qida Ekspozisiyası — Yeni qidanın baxma, toxunma, dadma və udma pillələri.

4. Doqquz Maddəli QYQTP Skrininqi (ing. Nine Item QYQTP Screen, NIAS) — 3 alt-tipi skrininq.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG69 — pilləli qida ekspozisiyası.
- Thomas J.J. KDT-AR — yeni sübut bazası.

9. Proqnoz

- Multidissiplinar yanaşma ilə əksər pasiyentlərdə yaxşılaşma müşahidə olunur.
- Autizm və OKP fonunda uzunmüddətli izləmə.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «QYQTP sadəcə seçici yemədir (ing. picky eating)»

Sübut: klinik diaqnoz əhəmiyyətli funksional pozulma və ya qidalanma çatışmazlığı tələb edir.

Mif 2: «Pasiyenti aclıqla yeyə məcbur etmək olar»

Sübut: aclıq strategiyası QYQTP-də effektsiz və ailə-uşaq münasibətinə zərərli; pilləli ekspozisiya (məruz qalma) tövsiyə olunur.

Mif 3: «QYQTP anoreksiyanın „yüngül forması“dır»

Sübut: ayrı klinik vahid; bədən obrazının pozulması və çəki qorxusu yoxdur; müdaxilə fərqlidir.

Mif 4: «Autizm fonunda QYQTP müalicə oluna bilməz»

Sübut: sensor inteqrasiya və davranış yanaşmaları autizm fonunda da təsirlidir.

Mif 5: «Pasiyent böyüdükcə pozuntu öz-özünə aradan qalxar»

Sübut: müalicəsiz pozuntu davam edə bilər; erkən müdaxilə qidalanma ilə bağlı komplikasiyaların qarşısını alır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B83 Qida qəbulundan çəkinmə/məhdudlaşdırma pozuntusu (QYQTP). 2024.

2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG69. 2017/2020.
4. Tomas C.C., Eddi K.T. Qida qəbulundan çəkinmə/məhdudlaşdırma pozuntusu (QYQTP) üçün koqnitiv-davranış terapiyası. Kembric Universiteti Nəşriyyatı; 2018.
5. Zikqraf H.F., Ellis C.M. Doqquz bəndli Qida qəbulundan çəkinmə/məhdudlaşdırma pozuntusu skrininq şkalasının (NIAS) ilkin etibarlılıq yoxlanışı (validasiya). «İştah» (Appetite). 2018;123:32–42.
6. Lok C., Le Qranj D. Anoreksiya nervoza üçün müalicə təlimatı: ailə əsaslı yanaşma. 2-ci nəşr. Nyu York: Quilford Nəşriyyatı; 2013.

XBT-11 **6B84**	**6B84 PİKA** **Pica**
XBT-10 F98.3	Körpələrin və uşaqların qeyri-qida maddələrini yeməsi
DSM-5-TR F98.3 / F50.89	Pika

1. Tərif və nozologiya

Pika (XBT-11: 6B84; DSM-5-TR: F98.3) — qida hesab edilməyən, qida dəyəri olmayan maddələrin (gil, saç, kağız, sabun, metal, daş) davamlı (≥ 1 ay) qəbulu ilə xarakterizə olunur və bu davranış inkişaf səviyyəsinə uyğun deyil.

2. Tarixçə

- «Pica» — latın «sağsağan» sözündən (sağsağan hər şeyi yeyir).
- DSM-III (1980) — uşaqlıq pozuntusu kimi.
- DSM-5-də (2013) bütün yaşlarda diaqnoz mümkündür.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: uşaqlarda 4–26%, intellektual əlilliyi olanlarda daha yüksəkdir, hamilə qadınlarda 8–65%, dəmir çatışmazlıq anemiyasında.
- Komorbidlik: autizm, intellektual əlillik, dəmir çatışmazlıq, böyüklərdə malabsorbsiya.

4. Etiologiya və patogenez

- Qidalanma çatışmazlıqları (dəmir, sink) — bəzi pasiyentlərdə pika maddələrinin yeyilməsi nəticəsində bu çatışmazlıq daha da arta bilər.
- Neyroinkişaf pozuntuları (autizm, intellektual əlillik — İƏ) müşahidə edilir.
- Hamiləlik — fizioloji və mikronutrient.
- Mədəni — bəzi ənənələrdə geofagiya (gil qəbulu).

5. Klinik təzahürlər

- Geofagiya (gil, torpaq), trixofagiya (saç), pagofagiya (buz), amilofagiya (nişasta), plumbofagiya (boya — qurğuşun riski).
- Komplikasiyalar: bağırsaq obstruksiyası (trikobezoar), qurğuşun zəhərlənməsi, parazitar infeksiya, diş zədəsi, perforasiya.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Qida dəyəri olmayan maddələrin davamlı qəbulu ≥ 1 ay.

B. Bu davranış fərdin inkişaf səviyyəsinə uyğun deyil.

C. Mədəni və ya sosial cəhətdən qəbul edilmiş təcrübə deyil.

D. Başqa psixi pozuntu, tibbi vəziyyət kontekstində baş verirsə — diaqnoz əlavə tələb edilir (xüsusilə İD və ASP-də).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR ən azı 1 aylıq müddət tələb edir; XBT-11-də müddət meyarı yoxdur — «klinik diqqət tələb edəcək qədər davamlı və ya ağır» deyilir. İnkişaf səviyyəsi hər iki mənbədə eyni qəbul edilir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Müsahibə + müşahidə.
2. Laborator müayinələr — ümumi qan analizi, ferritin, dəmir, qurğuşun və sink səviyyələri.
3. Qarın boşluğunun görüntülənməsi (obstruksiyanın istisnası).
4. Neyroinkişaf qiymətləndirməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
OKP (6B20)	Obsessiya əsaslıdır.
Faktisial pozuntu (6D50)	Xəstə rolunu almaq motivasiyası.
Anorexia obur yemə tip (6B80)	Bədən imajı.
Mədəni qida praktikası	Kontekst.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Dəmir, qurğuşun, sink, parazit testləri.
- Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası / ultrasəs müayinəsi (USM).

8. Müalicə

1. Qidalanma çatışmazlığının korreksiyası (dəmir, sink).
2. Davranış müdaxiləsi — vərdişin əvəzlənməsi (habit reversal), mühitin modifikasiyası, alternativ stimullar.
3. İntellektual əlillik və ASP fonunda — funksional davranış analizi (FBA) və tətbiqi davranış analizinə (ABA) əsaslanan yanaşma.
4. Komplikasiyaların tibbi idarəsi (qurğuşun zəhərlənməsi — xelat terapiyası yalnız müəyyən göstərişlər olduqda).
5. Hamiləlikdə — qidalanma ilə bağlı dəstək.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Funksional Davranış Analizi (FBA) — davranışın tətikləyicisi və saxlayıcısının müəyyənləşdirilməsi.
2. Mühit Modifikasiyası — Qeyri-qida maddələrinə əlçatanlığın məhdudlaşdırılması.
3. Qidalanmanın korreksiyası — Dəmir, sink, vitamin əlavələri.
4. ABA əsaslı müdaxilə — İD və ASP-də.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Amerika Pediatriya Akademiyası (AAP) — uşaqlarda pika qiymətləndirilməsi və qurğuşun skrininqi tövsiyə edir.

9. Proqnoz

- Uşaqlarda qidalanma ilə bağlı korreksiya və davranış müdaxiləsi ilə remissiya.
- İntellektual əlillik (İƏ) və antisosial şəxsiyyət pozuntusu (ASP) fonunda davam edə bilər; uzunmüddətli izləmə tələb olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pika sadəcə uşağın „kəşf etmə“ davranışıdır»

Sübut: 2 yaşa qədər bu davranış inkişafın normal mərhələsidir; sonrakı davam etməsi klinikdir və komplikasiya riski yaradır.

Mif 2: «Qurğuşun zəhərlənməsi hamı üçün xelyasiya tələb edir»

Sübut: xelyasiya yalnız təsdiqlənmiş yüksək səviyyədə (qanda qurğuşun səviyyəsi — BLL ≥ 45 mkq/dl olduqda); aşağı səviyyələrdə ətraf mühitin korreksiyası birinci sıra tədbirdir.

Mif 3: «Hamiləlikdə pika „uşağın istəyidir“, müdaxilə tələb etmir»

Sübut: dəmir və ya digər çatışmazlığın göstəricisidir; qidalanma ilə bağlı korreksiya tövsiyə edilir.

Mif 4: «İntellektual əlilliyi və ya ASP olan pasiyentlərdə pika qaçılmazdır»

Sübut: davranış müdaxilələri (ABA, FBA) effektivdir; «qaçınılmazdır» fikri trikobezoar və obstruksiya kimi ağır komplikasiyalara gətirib çıxarır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B84 Pika. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Yanq S.L. Hamiləlikdə pika: köhnə vəziyyət haqqında yeni fikirlər. «Qidalanma üzrə illik icmal» (Annu Rev Nutr). 2010;30:403–422.
4. Hayman S.L. və b. Amerika Pediatriya Akademiyasının (AAP) 2020-ci il Klinik Hesabatı (Autizm Spektr Pozuntusu, ASD). «Pediatriya» (Pediatrics). 2020;145(1):e20193447.

XBT-11 **6B85**	**6B85 RUMİNASİYA-REQURGİTASİYA POZUNTUSU** **Rumination-regurgitation disorder**
XBT-10 F98.21	—
DSM-5-TR F98.21	Ruminasiya pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Ruminasiya-Requrgitasiya Pozuntusu (XBT-11: 6B85; DSM-5-TR: F98.21) — udulmuş qidanın iradi və ya yarı-iradi geri qaytarılması (regurgitasiya) ardınca yenidən çeynənmə, yenidən udma və ya tüpürmə ilə xarakterizə olunur. Mədə-bağırsaq xəstəlikləri (qastroezofageal reflüks və s.) ilə tam izah olunmur.

2. Tarixçə

- Antik dövrdə «merisizm» termini.
- DSM-IV — körpə və uşaqlıq pozuntusu kimi.
- DSM-5 (2013) — bütün yaşlarda diaqnoz.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: körpə və uşaqlarda nadir; intellektual əlillikli pasiyentlərdə 6–10%; böyüklərdə (xüsusilə yemə pozuntusu ilə komorbid hallarda) tanınması artmaqdadır.
- Komorbidlik: İD, ASP, narahatlıq, BN, BED.

4. Etiologiya və patogenez

- Davranışın şərtlənməsi — yeməkdən sonrakı gəyirmə ardınca gələn regurgitasiya öyrənilmiş davranışa çevrilir.
- Stress və narahatlıq.
- İD/ASP-də qida ilə özünü stimullaşdırma.

5. Klinik təzahürlər

- Qida qəbulundan dəqiqələr–saatlar sonra regurgitasiya baş verir.
- Qidalanma pozuntusunun nəticələri: çəki itkisi, qidalanma çatışmazlığı, elektrolit pozulması, diş eroziyası, halitoz.
- Sosial nəticələr: utanc, sosial təcrid.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Udulmuş qidanın təkrarlanan regurgitasiyası — DSM-5-TR: ≥ 1 ay; XBT-11: həftədə bir neçə dəfə, ən azı bir neçə həftə ərzində; yenidən çeynənmə, udulma və ya tüpürmə.

B. Regurgitasiya tibbi vəziyyət (məs. reflüks, pilorik stenoz, piloroduodenal obstruksiya) ilə əlaqəli deyil.

C. Anorexia, bulimia, BED, QYQTP kontekstində baş vermir.

D. Başqa psixi pozuntu (xüsusilə İD, ASP) fonunda baş verirsə, klinik diqqət tələb edəcək qədər ağırdırsa, ayrıca qiymətləndirilməlidir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — meyarlar üst-üstə düşür; fərq yalnız müddətdədir: DSM-5-TR ≥ 1 ay tələb edir, XBT-11 — həftədə bir neçə dəfə ən azı bir neçə həftə ərzində və inkişaf yaşının ≥ 2 il olmasını.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Tibbi qiymətləndirmə — Qastroezofageal reflüks xəstəliyi (GERD), pilorik patologiya və qastroparez istisnası (yuxarı mədə-bağırsaq endoskopiyası, motillik tədqiqatı).
3. Manometriya — funksional regurgitasiyanın təsdiqi.
4. Çəki və qidalanma ilə bağlı vəziyyət.
5. Komorbid yemə pozuntusu skrininq.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
GERD	Tipik turş qaytarma; pH-monitorinq.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Bulimiya (6B81)	İradi qusma kompensator məqsədli.
Anorexia (6B80)	Çəki qorxusu.
Qastroparez	Motorika tədqiqatı.
Pylorik obstruksiya	Endoskopiya.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Endoskopiya, manometriya, pH-monitorinq.
- Ümumi qan analizi, elektrolitlər.

8. Müalicə

1. Diafraqmal tənəffüs — birinci sıra davranış müdaxiləsidir (Chitkara D.K. və b. Am J Gastroenterol 2006; effekt 50–70%).
2. Habit reversal — alternativ davranış öyrənmə.
3. Bioəks-əlaqə (biofeedback).
4. Stresin idarə edilməsi və KDT.
5. İD/ASP-də funksional davranış analizi və ABA.
6. Tibbi: GERD ilə birgə olduqda proton nasosu inhibitoru ilkin müdaxilə sayılır.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Diafraqmal Tənəffüs (ing. Diaphragmatic Breathing) — Qida qəbulundan sonra 5–10 dəqiqə yavaş qarın nəfəsi alma — regurgitasiyanın qarşısını alır.
2. Vərdiş əvəzləmə təlimi (ing. HRT, habit reversal training) — alternativ davranışın formalaşdırılması.
3. Bioəks-əlaqə (biofeedback) — Qarın əzələlərinə nəzarət.
4. FBA — funksional davranış analizi (İD/ASP-də) — Davranışın tətikləyici və saxlayıcısının analizi.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Roma Fondunun meyarları (funksional mədə-bağırsaq pozuntuları).
- NICE NG69 — yemə pozuntularının ümumi prinsipləri tətbiq edilir.

9. Proqnoz

- Diafraqmal tənəffüs və vərdiş əvəzləmə təlimi ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Ruminasiya GERD-in formasıdır»

Sübut: ayrı pozuntudur; manometriya və klinik model fərqlənir.

Mif 2: «Yalnız cərrahi müalicə (Nissen fundoplikasiyası) problemi həll edir»

Sübut: Nissen fundoplikasiya funksional ruminasiya üçün effektsiz və əks-göstərişdir; davranış müdaxiləsi birinci sıra müalicədir.

Mif 3: «Pasiyent iradəli davranır, ona görə yanaşma ardıcıllıq tələb edir»

Sübut: yarı-iradi davranışdır, şərti refleks (kondisionlaşma) əsaslıdır; cəza effektsizdir.

Mif 4: «Antiemetik effektivdir»

Sübut: antiemetiklər (məs. ondansetron) ruminasiyada effektsizdir.

Mif 5: «İD/ASP pasiyentdə dayandırılmaz»

Sübut: davranış müdaxilələri effektivdir; qidalanma ilə bağlı komplikasiyalar üçün aktiv müdaxilə vacib.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6B85 Ruminasiya-requrgitasiya pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Çitkara D.K., Van Tilburq M., Vaythed V.E., Talli N.C. Ruminasiya sindromunda diafraqmal tənəffüsün öyrədilməsi. «Amerika Qastroenterologiya Jurnalı» (Am J Gastroenterol). 2006;101(11):2449–2452.
4. Bağırsaq-beyin qarşılıqlı təsiri pozuntularının Roma IV diaqnostik meyarları. Roma Fondu; 2016.

6C00–6C0Z İFRAZAT POZUNTULARI

İfrazat pozuntuları

XBT-11 **6C00**	**6C00 ENUREZ** **Enuresis**
XBT-10 F98.0	Qeyri-üzvi mənşəli enurez
DSM-5-TR F98.0	Enurez

1. Tərif və nozologiya

Enurez (XBT-11: 6C00; DSM-5-TR: F98.0) — uşağın inkişaf yaşı ən azı 5 yaşa çatdıqda davam edən qeyri-iradi sidik buraxmadır. Müddət: həftədə ən azı 2 dəfə ≥ 3 ay və ya əhəmiyyətli funksional pozulma.

Alt-tiplər (ICCS — Beynəlxalq Uşaq Kontinens Cəmiyyəti, 2014):

- Monosimptomatik nokturnal enurez — yalnız gecə, gündüz simptomlar yox;
- Non-monosimptomatik enurez — gündüz simptomlar (təcili sidik ifrazı hissi, tezliyin artması, inkontinens) əlavə;
- İlkin (primary) — uşaq heç vaxt 6 ay davamlı quruluq əldə etməyib;
- İkincili (secondary) — quru dövrdən sonra residiv.

2. Tarixçə

- XIX əsrdə enurezin ailəvi yığılması klinik ədəbiyyatda qeyd olunmağa başlamışdır.
- Mowrer O.H. (1938) — yataq həyəcanvericisi (pad-and-bell) alarmını hazırlamışdır.
- ICCS (1989) — beynəlxalq terminologiyanın standartlaşdırılmasına başlanmışdır.
- NICE CG111 (2010) — gecə enurezi üzrə klinik göstərişdir.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: 5 yaş 15–20%, 7 yaş 5–10%, 10 yaş 3–5%, yetkin 1–2%.

- Cins: oğlanlarda qızlara nisbətən 2:1
- Spontan remissiya ildə təxminən 15%.
- Komorbidlik: DDHP təxminən 30%, narahatlıq, davranış pozuntuları, konstipasiya.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 70% (Bayoumi R.A.-nın icmalına görə).
- Üç əsas mexanizm (monosimptomatik nokturnal):
    - Gecə vazopressin (ADH) sekresiyasının yetkinləşməməsi (nokturnal poliuriya);
    - Oyanma astanasının yüksəkliyi;
    - Sidik kisəsi tutumunun yaş normasından kiçik olması.
- Non-monosimptomatik formada — sidik kisəsinin hiperaktivliyi, konstipasiya ilə əlaqə müəyyən edilir.
- Secondary enurez — stress, sidik yolları infeksiyası (UTI), diabet, psixiatrik tətikləyici.

5. Klinik təzahürlər

- Gecə yatağa sidik buraxma.
- Gündüz simptomlar (non-monosimptomatik): təcili sidik ifrazı hissi, sidiyi saxlama manevrləri (Vinsent reveransı, ayaqların sıxılması), tezliyin artması, inkontinens.
- Sosial-emosional: utanc, özünə qiymət azalması, sosial fəaliyyətdən qaçınma (düşərgəyə getməmə, yoldaşların evində gecələməmə).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR / XBT-11 / ICCS 2014)

A. Təkrarlanan sidik buraxma (yataqda və ya paltarda), iradi və ya qeyri-iradi.

B. Tezlik: həftədə ≥ 2 dəfə, ≥ 3 ay; və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət/funksional pozulma.

C. İnkişaf yaşı ≥ 5 yaş.

D. Maddə (diuretik) və ya tibbi vəziyyət (diabet, sidik yolları infeksiyası (UTI), struktur anomaliya) ilə tam izah olunmur.

Kvalifikatorlar: yalnız nokturnal / yalnız diurnal / nokturnal və diurnal; ilkin / ikincili; monosimptomatik / monosimptomatik olmayan.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ICCS 2014 — alt-tip terminologiyası standartı.
- NICE CG111 — diaqnoz və alqoritm.
- AAP — pediatrik qiymətləndirmə.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə — başlanğıc, tezlik, gündüz simptomlar, ailə tarixçəsi.
2. Sidik analizi və kulturası — UTI istisnası.
3. Voiding gündəliyi 3 gün — gündüz simptomlar üçün.
4. Konstipasiyanın qiymətləndirilməsi (Bristol nəcis şkalası).
5. Tibbi: çəki, qlükoza, qan təzyiqi.
6. Struktur anomaliya şübhəsi varsa — sidik yollarının ultrasəs müayinəsi (USM); uroflowmetriya non-monosimptomatik halda.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
UTI	Sidik kulturası pozitiv.
Diabet (Tip 1)	Poliuriya, polidipsiya; qlükoza yüksək.
Diabetes insipidus	Sidiyin nisbi sıxlığı aşağıdır.
Strukturel anomaliya (ektopik üreter)	Davamlı sızma; USG.
Neyrogen sidik kisəsi	Onurğa beyni patologiyası.
Konstipasiya	Klinik və Bristol Stool.
Tutma (ictal enuresis)	EEQ.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Sidik analizi, kultura.
- Sidik ifrazı və konstipasiya gündəliyi.
- Sidik yollarının ultrasəs müayinəsi (USM) (atipik klinik hallarda).
- Komorbid DDHP, narahatlıq skrininq.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (ICCS 2020, NICE CG111)

1. Davranış müdaxiləsi:
    - Konservativ tövsiyələr — yatmazdan əvvəl maye qəbulunun azaldılması, gündüz kifayət qədər su qəbulu, mütəmadi sidik buraxma, konstipasiyanın həlli.
    - Müsbət gücləndirmə (ulduz cədvəli) — quru gecələr üçün.
2. Birinci sıra xüsusi müdaxilə:
    - Enurez həyəcanvericisi (alarm) — yataq həyəcanvericisi (pad-and-bell); ≥ 6 yaşda, motivasiya varsa; uzunmüddətli yaxşı nəticə; ardıcıl 14 quru gecəyə çatanlar təxminən 50%, izləmədə quru qalanlar təxminən 40% (sübutun keyfiyyəti aşağı). Sübut: Caldwell P.H. Cochrane 2020.
    - Desmopressin — sintetik ADH analoqu; sürətli təsir, lakin kəsdikdə yüksək residiv. ≥ 6–7 yaş.
3. İkinci sıra:
    - Alarm + desmopressin kombinasiyası;
    - Antikolinergik (oksibutinin) — monosimptomatik olmayan sidik kisəsi hiperaktivliyi kontekstində.
4. Refrakter: imipramine (TCA) — kardial monitorinq; ehtiyatla, həddindən artıq doza toksikliyi.
5. Konstipasiyanın həlli — PEG (polietilen glikol) ilk sıra; non-monosimptomatik və ya komorbid enkoprez kontekstində.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Enurez Həyəcanvericisi (Alarm) — Mowrer — Yataq alarmı və ya paltar alarmı (rütubət sensoru); ≥ 4 həftə davamlı istifadə; tipik istifadə 12–16 həftə. Cochrane meta-analizi — uzunmüddətli təsiri ən yaxşı öyrənilmiş metod.
2. Desmopressin — oral 0,2–0,4 mq və ya sublingual forma şəklində; yatmazdan 1 saat əvvəl; axşam maye qəbulunun məhdudlaşdırılması vacibdir (hiponatriemiya riski).
3. Sidik ifrazı və konstipasiya gündəliyi — 3 günlük; tezlik, həcm, sidik kisəsi tutumu, gündüz simptomlar, defekasiya tezliyi.
4. Antikolinergik (Oksibutinin) — Over-active bladder fonunda; gündüz simptomlar varsa.
5. PEG (konstipasiyanın düzəldilməsi) — İlk sıra; enkoprezdə də istifadə.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- ICCS 2020 — alarm və desmopressin birinci sıra; «gözlə və izlə» 5 yaşa qədər, sonra aktiv müdaxilə.
- NICE CG111 — eyni alqoritm.
- AAP — pediatrik tövsiyələr.

9. Proqnoz

- Spontan remissiya ildə təxminən 15%; müdaxilə ilə əksər pasiyentdə remissiya.
- Konstipasiya idarəsi vacib.
- Komorbid DDHP, narahatlıq — paralel müdaxilə.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Gecə enurezində qasıq və omba nahiyəsinə elektroforez sidik mərkəzini stimullaşdırır»

Niyə yayılıb: Sovet dövrü fizioterapiya təcrübəsi; ailə həkimləri tərəfindən «təhlükəsiz» kimi təqdim edilir.

Klinik məntiq: əgər gündüz sidik ifrazı normaldır və problem hər hansı xəstəlikdən sonra spontan yaranmayıbsa, problem böyrək/sidik kisəsi/onurğa beyni səviyyəsində deyil. Patogenezi ADH sekresiyasının tənzimlənməsinin pozulması, oyanma astanasının yüksəlməsi və sidik kisəsi tutumunun azalması təşkil edir. — elektroforez bunlara təsir göstərmir.

Sübut: ICCS 2020, NICE CG111 — heç bir beynəlxalq göstərişdə elektroforez qeyd olunmur. Risk: dəri qıcıqlanması, psixoseksual yük.

Real klinik addım: alarm və ya desmopressin.

Mif 2: «Yalnız öz-özünə aradan qalxar, müdaxilə tələb etmir»

Sübut: spontan remissiya ildə təxminən 15%, lakin müalicəsiz uzanma sosial-emosional yük yaradır; ICCS 2020 — 5+ yaşdan aktiv müdaxilə tövsiyə edilir.

Mif 3: «Cəza və ya təhqir uşağı düzəldər»

Sübut: cəza əks-göstərişdir; özünə qiymət azalması, depressiya riski; müsbət gücləndirmə üstündür.

Mif 4: «Yatmazdan əvvəl su qəbulunun məhdudlaşdırılması tək kifayətdir»

Sübut: əlavə tədbir; tək başına əksər pasiyentdə təsirsizdir; xüsusi müdaxilə tələb olunur.

Mif 5: «İmipramin və ya antidepresan birinci sıra dərman sayılır»

Sübut: imipramin refrakter halda; kardial yan təsirlər və doza aşılması riski; alarm və desmopressindən üstündür.

Mif 6: «Akupunktur və homeopatiya enurezi sağaldır»

Sübut: Cochrane icmalları — bu tamamlayıcı müdaxilələrin təsiri sübut edilməyib.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C00 Enurez. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) CG111. 19 yaşdan kiçik uşaqlarda və yeniyetmələrdə gecə enurezi. 2010.
4. Neveus T. və b. Gecə enurezinin idarə edilməsi və müalicəsi — Uşaq Kontinensiyası üzrə Beynəlxalq Cəmiyyətin (ICCS) yenilənmiş standartlaşdırma sənədi. «Uşaq Urologiyası Jurnalı» (J Pediatr Urol). 2020;16(1):10–19.
5. Koldvell P.H., Kodarini M., Stüart F. və b. Uşaqlarda gecə enurezi üçün siqnal cihazı müdaxilələri. «Koçran Məlumat Bazası Sistematik İcmalları» (Cochrane Database Syst Rev). 2020;(5):CD002911.
6. Bayumi R.A., Eapen V., Əl-Yəhyai S. və b. İrsi ilkin gecə enurezinin genetik əsası: Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) aparılmış tədqiqat. «Psixosomatik Tədqiqatlar Jurnalı» (J Psychosom Res). 2006;61(3):317–320.

XBT-11 **6C01**	**6C01 ENKOPREZ** **Encopresis**
XBT-10 F98.1	Qeyri-üzvi mənşəli enkoprez
DSM-5-TR F98.1	Enkoprez

1. Tərif və nozologiya

Enkoprez (XBT-11: 6C01; DSM-5-TR: F98.1) — uşağın inkişaf yaşı ən azı 4 yaşa çatdıqda davam edən qeyri-uyğun yerlərə (paltarda, döşəmədə) iradi və ya qeyri-iradi defekasiyadır. Müddət: ayda ən azı 1 dəfə ≥ 3 ay.

Alt-tiplər:

- Retentiv (daşma inkontinensi) — konstipasiya əsasında; halların təxminən 80%-i;
- Non-retentiv — konstipasiya yox.

2. Tarixçə

- DSM-III (1980) — rəsmi diaqnoz.
- Roma IV — funksional qastrointestinal pozuntular çərçivəsində konsensusdur.
- NASPGHAN/ESPGHAN funksional konstipasiya rəhbərliyi (Tabbers M.M. və b. 2014).

3. Epidemiologiya

- 4–17 yaş arasında 1–4%; oğlanlarda qızlara nisbətən 3–6 dəfə yüksəkdir.
- təxminən 80% — konstipasiya əsaslı (retentiv).
- Komorbidlik: enurez, DDHP, narahatlıq, autizm spektri.

4. Etiologiya və patogenez

- Konstipasiya — əsas mexanizm (retentiv enkoprezdə); ağrılı defekasiya, tutma, rektal genişlənmə, həssaslığın azalması və daşma (overflow).
- Tualet təlimi prosesində travma, qorxu, intizam.
- Pəhriz (liflə zəif qidalanma, susuzlaşma).
- Davranış və emosional amillər — opozisional, narahatlıq.
- Az hallarda — Hirşsprung xəstəliyi (rektal aqanglionoz), spinal patologiya.

5. Klinik təzahürlər

- Paltarda fekal sızma (soiling).
- Retentiv — abdominal palpasiyada fekal kütlə; gərginmiş rektum; iri (massiv) defekasiya epizodları.
- Sosial-emosional: utanc, sosial təcrid, məktəbdən qaçınma.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Qeyri-uyğun yerlərə (paltara, döşəməyə) defekasiya, iradi və ya qeyri-iradi.

B. Tezlik: ayda ≥ 1 dəfə, ≥ 3 ay.

C. İnkişaf yaşı ≥ 4 yaş.

D. Maddə (laksativ) və ya tibbi vəziyyət (Hirschsprung, anatomik anomaliya, spinal patologiya) ilə tam izah olunmur.

Kvalifikator: konstipasiya və overflow ilə / olmadan.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NASPGHAN/ESPGHAN 2014 — funksional konstipasiya rəhbərliyi (Rome IV).
- NICE CG99 (2010) — NICE CG99 (2010) — uşaq və yeniyetmələrdə konstipasiya üzrə göstəriş.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə — defekasiya tezliyi, ağrı, tualet təlim tarixçəsi.
2. Abdominal palpasiya — fekal kütlə.
3. Rektal müayinə — fekal impaksiya (yaxud Hirschsprung xəstəliyinin klinik şübhəsi).
4. Defekasiya gündəliyi (ing. Bristol Stool Chart).
5. Tibbi: tiroid (hipotiroid konstipasiya), serum kalsium, çölyak xəstəliyi skrininq.
6. Atipik klinik: USG, anorektal manometriya, sorucu (aspirasiya) biopsiyası (Hirschsprung).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Hirschsprung xəstəliyi	Doğuşdan konstipasiya; rektal müayinədə dar; biopsiyada aqanglionoz.
Hipotiroid	TSH.
Spinal patologiya	Neyroloji əlamətlər; MRT.
Çölyak xəstəliyi	Anti-tTG.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Anal struktur anomaliya	Fiziki müayinə, ultrasəs müayinəsi (USM)

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Abdominal və rektal müayinə.
- Bristol Stool, defekasiya gündəliyi.
- TSH, kalsium, anti-TTG seçici.
- USG, manometriya atipik halda.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NASPGHAN/ESPGHAN, NICE CG99)

1. İmpaksiyanın aradan qaldırılması (disimpaction) — PEG (polietilen glikol) yüksək dozada 3–7 gün; oral yol üstündür; enema tövsiyə edilmir — travmatikdir.
2. Saxlama (saxlayıcı müalicə) — PEG 0,4 q/kq/gün, aylar, illər ərzində; defekasiyanın müntəzəm və ağrısız davam etməsini təmin edir.
3. Davranış müdaxiləsi:
    - Mütəmadi tualet vaxtı (yeməkdən 15–20 dəq sonra, qastrokolik refleks);
    - Doğru ayaq dəstəyi (defekasiya pozisiyası);
    - Müsbət gücləndirmə (cəza yox).
4. Pəhriz: liflə zəngin qidalanma, su qəbulunun artırılması (mülayim effekt; PEG-i əvəzləmir).
5. Psixoloji dəstək: sıxıntının azaldılması, ailə təlimi.
6. Refrakter halda biofeedback, multidissiplinar yanaşma; cərrahi nadir (Malone-anteqrad enema).

8.2 Müalicə metodikaları

1. PEG (ing. Polietilen Glikol) — Osmotik laksativ; disimpaction 1–1,5 q/kq/gün × 3 gün; saxlama 0,4 q/kq/gün; aylar-illər; yan təsirlər minimal.
2. Tualet Vaxtı və Pozisiyası — Yeməkdən 15–20 dəq sonra 5–10 dəqiqəlik tualet; ayaq dəstəyi — bud-çanaq bükülməsi anorektal bucağı düzəldir və zorlanmanı azaldır; videomanometriyada defekasiya zamanı anorektal bucaq

oturaq vəziyyətdə təxminən 100°, çöməltmədə təxminən 126° təşkil edir (Sakakibara R. və b. LUTS 2010).

3. Müsbət gücləndirmə (ulduz cədvəli — star chart) — Cəza əvəzinə müsbət davranış mükafatı.
4. Biofidbek (Biofeedback) — Refrakter halda; anorektal koordinasiya təlimi.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NASPGHAN/ESPGHAN 2014 — PEG birinci sıra; enema travmatik və ikinci sıra.
- NICE CG99 — eyni.
- Cochrane (Gordon M. və b. 2016) — PEG laktuloza ilə müqayisədə üstündür.

9. Proqnoz

- PEG və davranış müdaxiləsi ilə əksər pasiyentdə remissiya (50–80% 1 ildə).
- Uzunmüddətli saxlama tövsiyə edilir; erkən kəsmə residiv riski yaradır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Enkoprez psixoloji „inadkarlıq“ və ya emosional pozuntu nəticəsidir»

Sübut: təxminən 80% halları konstipasiya əsaslıdır; tibbi/davranış konsultasiya birinci sıradır, psixoloji deyil. Davranışın «qəsdən» edildiyi izahı yanlışdır.

Mif 2: «Cəza ilə uşağı düzəltmək olar»

Sübut: NASPGHAN/ESPGHAN — cəza əks-göstərişdir; özünə qiymət və sıxıntı artırır.

Mif 3: «Enema birinci sıra müdaxilədir»

Sübut: oral PEG üstündür; enema travmatikdir, ikinci sıra.

Mif 4: «Pəhriz dəyişikliyi tək kifayətdir»

Sübut: lif və su qəbulunun təsiri mülayimdir, əlavə tədbir kimi çıxış edir; impaksiya korreksiyası və saxlama PEG tələb edir.

Mif 5: «Enkoprez yaşla aradan qalxar, müalicə tələb etmir»

Sübut: müalicəsiz xronikləşmə, sosial-emosional yük; aktiv müdaxilə tövsiyə olunur.

Mif 6: «Probiotiklər enkoprezi sağaldır»

Sübut: Cochrane — probiotiklərin əhəmiyyətli effekti sübut edilməyib.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C01 Enkoprez. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Tabbers M.M. və b. Körpələrdə və uşaqlarda funksional qəbizliyin qiymətləndirilməsi və müalicəsi: Avropa Uşaq Qastroenterologiyası, Hepatologiyası və Qidalanması Cəmiyyətinin (ESPGHAN) və Şimali Amerika Uşaq Qastroenterologiyası, Hepatologiyası və Qidalanması Cəmiyyətinin (NASPGHAN) sübuta əsaslanan tövsiyələri. «Uşaq Qastroenterologiyası və Qidalanması Jurnalı» (J Pediatr Gastroenterol Nutr). 2014;58(2):258–274.
4. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) CG99. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə qəbizlik. 2010.
5. Qordon M. və b. Uşaq qəbizliyinin idarə edilməsində osmotik və stimullaşdırıcı laksativlər. «Koçran Məlumat Bazası Sistematik İcmalları» (Cochrane Database Syst Rev). 2016;(8):CD009118.
6. Sakakibara R., Tsunoyama K., Hosoi H. və b. İnsanlarda bədən mövqeyinin defekasiyaya təsiri. «Aşağı Sidik Yolları Simptomları» (LUTS). 2010;2(1):16–21.

6C20 BƏDƏNİ ƏZAB-ƏZİYYƏT

Bədən distressi və ya bədən təcrübəsi pozuntuları

XBT-11 **6C20**	**6C20 BƏDƏN DİSTRESSİ POZUNTUSU** **Bodily distress disorder**
XBT-10 F45.0	Somatizasiya pozuntusu
DSM-5-TR F45.1	Somatik simptom pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

XBT-11: 6C20 bədən distressi pozuntusu (ing. bodily distress disorder); DSM-5-TR: F45.1 somatik simptom pozuntusu (ing. somatic symptom disorder) — somatik şikayətlərin (ağrı, yorğunluq, qastrointestinal və ya kardiopulmoner simptomlar) həddindən artıq diqqət, narahatlıq və davranış dəyişikliyi yaratdığı, funksional pozulma ilə müşayiət olunan psixiatrik pozuntudur. Klinik diaqnoz simptomların «izah edilə bilməməsi» əsasında deyil, davamlı məşğuliyyət və əzab-əziyyət əsasında qoyulur (DSM-5-TR yeniləməsinin əsas dəyişikliyi).

2. Tarixçə

- Briquet P. (1859) — «isteriya» çoxsaylı somatik simptomlarla.
- DSM-III (1980) — «Somatizasiya pozuntuları» qrupu.
- DSM-5 (2013) — əsaslı dəyişiklik: «tibbi izah edilməyən simptomlar» tələbi ləğv edildi; somatik simptomun real olub-olmaması meyar deyil — pasiyentin reaksiyası diaqnostik diqqət mərkəzindədir.
- XBT-11 (2019) — «Bədən distressi pozuntusu» — bədən distressi (ing. bodily distress) üzrə Avropa modelinə əsaslanır (Fink P., Schröder A.).

3. Epidemiologiya

- İlkin tibbi yardım mərhələsində 5–15% təşkil edir.
- Cins: qadınlarda kişilərə nisbətən 2–3 dəfə yüksəkdir.

- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, panik, süni pozuntu (faktisioz), real tibbi xəstəliklər.
- Yüksək tibbi xidmət istifadəsi və xərclər.

4. Etiologiya və patogenez

- Biopsixososial model — bioloji həssaslıq, koqnitiv-affektiv emosional komponentlər və sosial gücləndirmə.
- Travma və uşaqlıq xəstəlikləri tarixçəsi.
- Koqnitiv — bədən sensasiyalarının fəlakətləşdirilməsi və artmış sayıqlıq (hipervijilans).

5. Klinik təzahürlər

- Davamlı somatik simptomlar (ağrı, yorğunluq, qastrointestinal, kardiopulmoner).
- Aşağıdakılardan ≥ 1:
    - Simptomların ciddiyyəti haqqında həddən artıq və davamlı fikir;
    - Sağlamlıqla bağlı yüksək narahatlıq;
    - Simptomlara həddən artıq vaxt və enerji sərf edilməsi.
- Müddət ≥ 6 ay.
- Funksional pozulma.
- «Həkim dəyişdirmə» (doctor shopping), təkrar yoxlama, qaçınma davranışı müşahidə olunur.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Bir və ya bir neçə somatik simptom — pasiyentdə distres və ya funksional pozulma yaradır.

B. Aşağıdakılardan ≥ 1:

1. Simptomların ciddiyyəti haqqında həddən artıq fikir;
2. Sağlamlıqla bağlı yüksək narahatlıq;
3. Simptomlara həddən artıq vaxt/enerji.

C. Davamlılıq ≥ 6 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — «ağrının üstünlük təşkil etməsi ilə» (with predominant pain) və şiddət göstəriciləri.
- XBT-11 — «Bodily Distress Disorder» — Avropa «bədən distressi sindromu» (bodily distress syndrome) konsepsiyasına yaxın; şiddət (yüngül, orta, ağır).
- Almaniya S3 təlimatı (funksional bədən şikayətləri, 2018) — biopsixososial yanaşma.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Somatik simptom şkalası (PHQ-15), somatik simptom şkalası-8 (SSS-8).
3. Tibbi qiymətləndirmə — somatik xəstəlik istisnası (lakin həddindən artıq müayinədən qaçınmaq).
4. Komorbidlik (TDP, narahatlıq, süni pozuntu, real xəstəliklər).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Hipoxondriya (6B23)	Xəstəlik narahatlığı dominantdır; somatik simptomlar minimaldır.
Real tibbi xəstəlik	Klinik və laborator təsdiq; lakin somatik simptom pozuntusu komorbid ola bilər.
FND (6B60)	Spesifik nevroloji simptomlar; pozitiv əlamətlər (ing. positive signs).
süni pozuntu (6D50)	Şüurlu yalan; qazanc motivasiyası.
Simulyasiya	Aşkar maddi və ya hüquqi qazanc.
TDP somatik forması	Affektiv simptomlar dominant.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PHQ-15, SSS-8, Whiteley Index (üst-üstə düşmə).
- Bir dəfəlik kompleks tibbi yoxlama aparılır; sonra təkrar yoxlamalar minimal olur.
- Komorbidlik şkalaları tətbiq edilir.

8. Müalicə

1. Biopsixososial yanaşma və «pilləli yardım» — birinci tibbi yardım həkimi mərkəz, psixiatr/psixoloq köməkçi rolunda.
2. Tək həkim modeli — bütün şikayətlər həmin həkim vasitəsilə idarə olunur.
3. KDT (koqnitiv davranış terapiyası) — koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, bədən duyğularının fəlakətləşdirilməsinin azaldılması, davranış aktivasiyası. Sübut: van Dessel N. Cochrane 2014 (CD011142).
4. SSGİ — komorbid TDP/narahatlıq; ağrı dominant olduqda duloksetin, amitriptilin.
5. Strukturlaşdırılmış məhdud yoxlama — pasiyentə bir dəfə kompleks yoxlama, sonra sakitləşdirici izahat məhdud şəkildə verilir.
6. Şüurlu diqqət (ing. mindfulness), fiziki fəallıq və peşə reabilitasiyası tətbiq edilir.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Somatik simptom pozuntusu üçün KDT — Koqnitiv yenidən strukturlaşdırma + davranış müdaxiləsi (qaçınmanın azaldılması, ekspozisiya (məruz qalma)). van Dessel N. Cochrane 2014 (CD011142).
2. Tək Həkim Modeli — Strukturlaşdırılmış vizitlər; məhdud sayda yoxlama; ardıcıl izahat.
3. PHQ-15, SSS-8 — Somatik şikayət şkalaları.
4. Pilləli Yardım (ing. Stepped Care) — Birinci tibbi yardım səviyyəsində KDT-əsaslı qısa müdaxilə; sonra ixtisaslaşmış xidmət.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Alman S3 təlimatı — birinci tibbi yardım səviyyəsində inteqrasiya olunmuş qayğı.
- NICE — somatik simptom pozuntusu üçün ayrı göstəriş yoxdur; ümumi prinsiplər.

9. Proqnoz

- KDT və multidissiplinar yanaşma ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma; xronik gediş.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pasiyent simptomları „uydurur“»

Sübut: simptomlar pasiyent üçün gerçəkdir; somatik pozuntu klinik vəziyyətdir, simulyasiya deyil.

Mif 2: «Tibbi yoxlamadan sonra „heç nə yoxdur“ deyilməsi pasiyenti rahatlaşdırar»

Sübut: «heç nə yoxdur» tipli inandırma yalnız qısamüddətli təsir verir; uzunmüddətli narahatlığı isə saxlayır. Strukturlaşdırılmış izahat və biopsixososial model üstündür.

Mif 3: «Yalnız uzun sürən tibbi tədqiqat diaqnozu müəyyən edə bilər»

Sübut: təkrar yoxlama somatik simptomlara diqqəti və xərcləri artırır; bir dəfə kompleks qiymətləndirmə, sonra isə məhdud yoxlamalar aparılır.

Mif 4: «Somatik simptom pozuntusu yalnız „ağıl xəstəliyi“dir»

Sübut: biopsixososial pozuntudur; bioloji komponentlər (sensitizasiya, bağırsaq-beyin oxu) realdır.

Mif 5: «Antidepresanlar somatik simptom pozuntusunun müalicəsidir»

Sübut: SSGİ komorbid simptomlar üçün tətbiq edilir; KDT isə birinci sıra müalicədir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C20 Bədən narahatlığı pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Kleynştoyber M. və b. Böyüklərdə somatoform pozuntular üçün farmakoloji müdaxilələr. «Koçran Məlumat Bazası Sistematik İcmalları» (Cochrane Database Syst Rev). 2014;(11):CD010628.
4. Henningsen P. və b. Somatik simptom pozuntusunun idarə edilməsi. «Klinik Neyroelmlər üzrə Dialoqlar» (Dialogues Clin Neurosci). 2018;20(1):23–31.
5. Şefert R. və b. Qeyri-spesifik, funksional və somatoform bədən şikayətləri. «Almaniya Həkimlər Jurnalı» (Dtsch Arztebl Int). 2012;109(47):803–813.
6. van Dessel N. den Buft M. van der Vouden C.C. və b. Böyüklərdə somatoform pozuntular və tibbi izahatı olmayan fiziki simptomlar (MUPS) üçün qeyri-farmakoloji müdaxilələr. «Koçran Məlumat Bazası Sistematik İcmalları» (Cochrane Database Syst Rev). 2014;(11):CD011142.

6C40–6C5Z MADDƏ İLƏ ƏLAQƏLİ

Maddə istifadəsi və asılılıq davranışları ilə bağlı pozuntular (ing. Disorders due to substance use or addictive behaviours)

XBT-11 **6C40**	**6C40 ALKOQOL QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **Disorders due to use of alcohol**
XBT-10 F10	Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları
DSM-5-TR F10.20	Alkoqol istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Alkoqol Qəbulundan Qaynaqlanan Pozuntular (XBT-11: 6C40; DSM-5-TR: alkoqol istifadəsi pozuntusu (AİP); XBT-10-KM: F10.20) — alkoqol istifadəsinə nəzarətin pozulması, alkoholun fiziki və ya psixoloji zərər yaratmasına baxmayaraq davam etdirilməsi ilə xarakterizə olunan pozuntular qrupudur. XBT-11-də alt-tiplər: zərərli istifadə nümunəsi (6C40.1), alkohol asılılığı (6C40.2), intoksikasiya (6C40.0), kəsilmə sindromu (6C40.3), alkohol induksiyalı delirium, psixotik, əhval və narahatlıq pozuntuları.

2. Tarixçə

- Jellinek E.M. (1960) — «The Disease Concept of Alcoholism» — alkoholizm xəstəlik kimi.
- DSM-IV — «sui-istifadə» və «asılılıq» ayrı kateqoriyalar kimi müəyyən edilmişdir.
- DSM-5 (2013) — vahid «alkoqol istifadəsi pozuntusu» (yüngül, orta, ağır şiddət).
- XBT-11 — zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılığın bir-birindən ayrılması.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 14–29% (ing. NIAAA NESARC); illik 5–14%.
- Cins: kişilərdə 2–3 dəfə yüksək, lakin qadınlarda artmaqdadır.
- Mortalite: dünyada ildə 2,6 mln ölüm (ÜST).
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, PTSP, ŞPP, başqa maddə istifadəsi, qaraciyər xəstəliyi, kardiovaskulyar pozuntular.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik təxminən 49% (95% Eİ 43–53) (Verhulst B. və b. Psychol Med 2015).
- Neyrobioloji — dopamin mükafat dövrəsi, GABA, qlutamat, opioid sistemləri.
- Mühit — həmyaşıdların təsiri, stress, alkoqolun əlçatanlığı, mədəni normalar.
- Genetik markerlər — ADH1B, ALDH2 (Asiya əhalisində qoruyucu).

5. Klinik təzahürlər

5.1 Asılılıq sindromu (DSM-5-TR meyarları, 11 meyardan ən azı 2-si)

- Daha çox/daha uzun istifadə;
- Azaltmaq cəhdləri uğursuz olur;
- Vaxtın böyük hissəsi maddə əldə etmək, onu istifadə etmək və sağalmaqla keçir;
- Maddəyə güclü istək (craving);
- İş/məktəb pozulması;
- Sosial-şəxslərarası problemə baxmayaraq davam;
- Vacib fəaliyyətlərdən imtina;
- Təhlükəli situasiyada istifadə;
- Fiziki/psixoloji problemə baxmayaraq davam;
- Tolerans;
- Kəsilmə sindromu.

5.2 İntoksikasiya

- Disinhibisiya, dizartria, ataksiya, nistaqm, koqnitiv pozulma.
- Ağır intoksikasiya — koma, respirator depressiya, hipoglikemiya, ölüm.

5.3 Kəsilmə (withdrawal)

- Yüngül: tremor, tər, taxikardiya, narahatlıq, ürək bulanması (son içkidən 6–24 saat).
- Orta: autonom hiperaktivlik, hallüsinasiyalar (alkoqol hallüsinozu).
- Ağır: delirium tremens (DT) — 48–96 saat; şüur dəyişiklikləri, hallüsinasiyalar, autonom kriz; hospitalizasiya olunmuş pasiyentlərdə letallıq təxminən 1–4% (Schuckit M.A. N Engl J Med 2014); müalicəsiz tarixi seriyalarda isə xeyli yüksək olmuşdur; tutmalar da müşahidə edilir.

5.4 Fəsadlar

- Wernicke-Korsakoff (B1 çatışmazlığı), alkoqol qaraciyər xəstəliyi, kardiyomiopatiya, polinevropatiya, FAS hamiləlikdə.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR — 11 meyardan ≥ 2 (yüngül 2–3, orta 4–5, ağır ≥ 6); XBT-11 — istifadə paterni (zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni, asılılıq); «təhlükəli istifadə» 6C4x-ə deyil, QE10 koduna aiddir. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay; asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 1 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- WHO AUDIT (Saunders 1993) — 10 maddəlik skrininq.
- NICE CG115 — alkohol pozuntularının diaqnozu və müalicəsi.
- SAMHSA TIP — ABŞ üçün milli protokollar.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. AUDIT (Alkoqol İstifadəsi Pozuntularının Müəyyənləşdirilməsi Testi) və AUDIT-C skrininqi birinci tibbi yardım səviyyəsində aparılır.
2. Klinik müsahibə — TLFB (ing. Timeline Followback) istifadə paterni.
3. Laborator: GGT, AST/ALT, MCV, CDT (karbohidrat çatışmazlığı transferrini), ümumi qan analizi.
4. Komorbidlik (TDP, narahatlıq, PTSP, somatik xəstəliklər).
5. Kəsilmə riski (CIWA-Ar).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Başqa maddə istifadəsi	Toksikoloji skrininq.
TDP ilə özünü müalicə	Affektiv simptomlar birinci plandadır.
Bipolyar pozuntu	Affektiv epizodlar.
Hipertiroid	TSH.
Tutma pozuntusu	EEQ.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- AUDIT, CIWA-Ar (kəsilmə şiddəti).
- Laborator göstəricilər: GGT, MCV, CDT, transaminazalar.
- Tiamin səviyyəsi.
- EKG, EKG, ürəyin exokardioqrafiyası (kardiyomiopatiya).
- Komorbidlik skrininq.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG115, SAMHSA TIP 49, APA 2018)

1. Detoksifikasiya:
    - Yüngül (CIWA-Ar < 10) — ambulator;
    - Orta-ağır — hospitalizasiya;
    - Benzodiazepinlər (lorazepam, diazepam) — qızıl standart kəsilmə müalicəsi;
    - Tiamin 100–300 mq IV/IM × 3–5 gün (Wernicke profilaktikası — qlükozadan əvvəl);
    - Hidratasiya, elektrolit korreksiyası.
2. Residiv əleyhinə farmakoterapiya:
    - Naltrekson (oral 50 mq və ya IM Vivitrol 380 mq aylıq) — birinci sıra; maddəyə güclü istəyi azaldır.
    - Akamprosat (666 mq × 3 dəfə/gün) — birinci sıra; abstinensiyanın saxlanması.
    - Disulfiram — ikinci sıra; motivasiyalı pasiyentdə; aversiv reaksiya.

- Topiramat, gabapentin — göstərişdən kənar (ing. off-label) tətbiq edilir.

3. Psixososial: Motivasiya müsahibəsi (MI), KDT, 12-Step facilitation (AA, NA), kontingens idarəetmə.
4. SAMHSA — birgə istifadə pozuntusu və psixiatrik komorbidlik (dual diagnosis).
5. Uzunmüddətli residiv profilaktikası aparılır.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Motivasion Müsahibə (ing. MI — Motivational Interviewing) — Miller (Miller W.R.), Rollnick S. — Davranış dəyişikliyinə hazırlığın artırılması; ikimənalılığa (ing. ambivalence) yönəlir.
2. Maddə istifadəsi üçün KDT — Tətikləyicilərin tanınması, cravings idarəsi, başa çıxma bacarıqları, residiv profilaktikası.
3. Naltrekson, Akamprosat, Disulfiram — Residiv əleyhinə farmakoterapiya.
4. 12 Addım Proqramının Dəstəyi (ing. 12-Step Facilitation — AA, NA) — Project MATCH tədqiqatı — KDT və MI ilə müqayisəli effekt.
5. AUDIT, CIWA-Ar — Skrininq və kəsilmə şiddəti.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG115 (2011).
- APA Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients with Alcohol Use Disorder (2018).
- SAMHSA TIP 49 (2009).

9. Proqnoz

- Multimodal yanaşma ilə 40–50% uzunmüddətli remissiya.
- Komorbid TDP, ŞPP, başqa maddə istifadəsi — əlverişsiz proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Alkoholizm xarakter zəifliyidir»

Sübut: Jellinek 1960; WHO — alkohol istifadəsi pozuntusu tibbi vəziyyətdir; irsilik 50–60%.

Mif 2: «Detoksifikasiya tək başına müalicədir»

Sübut: detoks ilk addımdır; residiv əleyhinə müdaxilə tələb olunur; tək detoks 90%+ residiv.

Mif 3: «Naltrekson alkoholu „qəbul edilməz“ edir»

Sübut: naltrekson maddəyə güclü istəyi (craving) və alkoholun mükafat effektini azaldır; disulfiramdan fərqlidir.

Mif 4: «Müalicə başlamazdan əvvəl pasiyent dip nöqtəyə (ing. rock bottom) çatmalıdır»

Sübut: erkən müdaxilə daha effektivdir; «dip nöqtə» (ing. rock bottom) anlayışı sübuta əsaslanmır.

Mif 5: «Alkohol ən təhlükəsiz maddədir, müalicə tələb etmir»

Sübut: ÜST — alkoqol illik 2,6 mln ölümə səbəb olur (ÜST 2024, 2019 məlumatları); DT letallığı hospitalizasiya olunmuş pasiyentlərdə təxminən 1–4% (Schuckit M.A. N Engl J Med 2014); müalicəsiz tarixi seriyalarda xeyli yüksək.

Mif 6: «Hamilə qadın üçün „az alkoqol təhlükəsizdir“»

Sübut: CDC, AAP — hamiləlikdə hər miqdar alkohol FAS riski yaradır; «təhlükəsiz» doza yoxdur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C40 Alkoqol istifadəsi ilə bağlı pozuntular. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) CG115. Alkoqol istifadəsi pozuntuları: diaqnostika, qiymətləndirmə və idarəetmə. 2011.
4. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Alkoqol istifadəsi pozuntusu olan xəstələrin farmakoloji müalicəsi üzrə təcrübə təlimatı. 2018.
5. ABŞ Maddə Aludəçiliyi və Ruhi Sağlamlıq Xidmətləri Administrasiyası (SAMHSA). TIP 49: Alkoqol farmakoterapiyalarının tibbi praktikaya daxil edilməsi. 2009.
6. Anton R.F. və b. COMBINE sınağı. «JAMA». 2006;295(17):2003–2017.
7. Project MATCH Tədqiqat Qrupu. Alkoqolizm müalicələrinin pasiyentin heterogenliyinə uyğunlaşdırılması. «Alkoqol Tədqiqatları Jurnalı» (J Stud Alcohol). 1997;58(1):7–29.

8. Verhulst B., Neale M.C., Kendler K.S. Alkoqol istifadəsi pozuntularının irsilik dərəcəsi: əkiz və övladlığa götürmə tədqiqatlarının meta-analizi. «Psixoloji Tibb» (Psychol Med). 2015;45(5):1061–1072.
9. Şukit M.A. Çəkilmə deliriya (ing. delirium tremens) tanınması və idarə edilməsi. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (N Engl J Med). 2014;371(22):2109–2113.
10. Saunders C.B., Aasland O.Q., Babor T.F. və b. Alkoqol İstifadəsi Pozuntularının Müəyyənləşdirilməsi Testinin (AUDIT) hazırlanması. «Addiction». 1993;88(6):791–804.
11. Miller V.R., Rollnik S. Motivasiya Müsahibəsi: İnsanlara Dəyişməyə Kömək Etmək. 3-cü nəşr. Nyu York: Guilford Press; 2013.

XBT-11 **6C41**	**6C41 KANNABİNOİDLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **Disorders due to use of cannabis**
XBT-10 F12	Kannabisdən istifadə nəticəsində yaranan psixi və davranış pozuntuları
DSM-5-TR F12.20	Kannabis istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Kannabis İstifadəsi Pozuntuları (XBT-11: 6C41; DSM-5-TR: F12.20) — THC (tetrahidrokannabinol) tərkibli kannabisdən istifadəyə nəzarətin pozulması və/yaxud zərərli istifadə. Sintetik kannabinoidlər XBT-11-də ayrıca kodlanır (6C42).

2. Tarixçə

- DSM-III (1980) — «kannabis asılılığı» rəsmi diaqnoz kimi təsdiq edilmişdir.
- DSM-5 (2013) — «kannabis kəsilməsi» formal kateqoriya kimi əlavə edildi.
- 2010+ — yüksək potensiyalı kannabis və sintetik kannabinoidlər («Spice», «K2») epidemiyası.

3. Epidemiologiya

- Asılılığın inkişaf riski: 7–9% kannabis istifadəçiləri arasında asılılıq inkişaf edir; yeniyetməlikdə başlayanlarda risk 17%.
- Cins: kişilərdə yüksəkdir.
- Komorbidlik: psixoz riski, narahatlıq, TDP, DDHP, başqa maddə istifadəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 50–60%.
- Endokannabinoid sistemi.
- Sosial və mədəni faktorlar; əlçatanlıq.

5. Klinik təzahürlər

- Asılılıq sindromu (AUD ilə eyni meyarlar).
- İntoksikasiya — qızarmış göz, taxikardiya, iştahın artması, zaman qavrayışı pozuntusu, hiss qavrayışının qarışması.
- Ağır intoksikasiya — kannabinoid hiperemezis sindromu (xronik istifadədə qusma sindromu), panika, psixoz.
- Kəsilmə (DSM-5 yeni): qıcıqlanma, narahatlıq, yuxu pozulması, iştahın azalması, əhval-ruhiyyənin aşağı düşməsi, somatik şikayətlər; 24–72 saatda başlanır, 1–2 həftə davam edir.
- Sintetik kannabinoidlər («Spice», «K2») daha güclüdür və gözlənilməz təsir göstərir; ağır intoksikasiya, kəskin psixoz və ölüm halları müşahidə edilir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR — 11 meyar (AUD strukturu). XBT-11 DSM-5-TR-in vahid şkalasından fərqli olaraq üç ayrıca kateqoriya işlədir: zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılıq. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay; asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 3 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NIDA (Narkomaniya üzrə Milli İnstitut) — kannabis istifadəsi pozuntusu üzrə prinsiplər.

- ÜST mhGAP (Psixi sağlamlıq üzrə boşluqların aradan qaldırılması proqramı) — birinci tibbi yardım səviyyəsində qiymətləndirmə aparılır.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə aparılır.
2. Kannabis İstifadəsi Pozuntusunun Müəyyənləşdirilməsi Testi–Yenilənmiş (CUDIT-R).
3. Toksikoloji skrininq (sidikdə tetrahidrokannabinol — THK).
4. Komorbid psixoz, narahatlıq, TDP.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Sintetik kannabinoid pozuntusu (6C42)	Daha güclü psixotik və avtonom təsir.
Psixoz (kannabis induksiyalı və ya primer)	Maddə qəbulu dayandırıldıqdan sonra simptomların davam etməsindən asılıdır.
Funksional qastrointestinal pozuntu (kannabinoid hiperemezis sindromu)	İstifadə kəsilməsi ilə remissiya.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- CUDIT-R.
- Toksikoloji.
- Komorbidlik (psixoz, narahatlıq, TDP).

8. Müalicə

1. Psixososial müdaxilə birinci sıradır — MI, KDT, kontingens idarəetmə. Sübut: Davis M.L. və b. Eval Health Prof 2015 meta-analiz.
2. Spesifik FDA təsdiqli farmakoterapiya yoxdur. Təsdiqlənməmiş göstərişlər üzrə (off-label): N-asetilsistein (yeniyetmələrdə Gray K.M. Am J Psychiatry 2012 RKİ müsbət — yalnız kontingens idarəetmə platformasında; böyüklərdə Gray K.M. Drug Alcohol Depend 2017 RKİ mənfi), gabapentin.
3. Komorbid psixoz — antipsixotik; kannabisdən imtina kritik.
4. Sintetik kannabinoid intoksikasiyası — dəstəkləyici müalicə, lazım olduqda atipik antipsixotik təyin edilir.

8.1 Müalicə metodikaları

1. KDT və Motivasiya müsahibəsi (MM) — Tətikləyicilərin idarəsi, motivasiyanın gücləndirilməsi və davranış dəyişikliyi həyata keçirilir.
2. Kontingensiya İdarəsi (ing. Contingency Management) — Mənfi toksikoloji testlər üçün mükafat.
3. CUDIT-R — 8 maddəlik skrininq.
4. N-asetilsistein (NAC) — Yeniyetmələrdə erkən müsbət nəticə təkrarlanmadı (Cochrane 2025: nisbi risk 1,17; 95% etimad intervalı 0,73–1,88) — eksperimental; təsdiqlənməmiş göstərişlər üzrə (off-label).

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Narkotiklərlə Mübarizə üzrə Milli İnstitut (NIDA) — KDT və kontingens idarəetməni birinci sıra müalicə hesab edir.
- WHO mhGAP.

9. Proqnoz

- Psixososial müdaxilə ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Erkən istifadə başlanğıcı — pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Kannabis „təbii“dir, asılılıq yaratmır»

Sübut: Kannabis istifadəsi pozuntusu (KİP) istifadəçilərin 7–9%-də ömür boyu inkişaf edir; yeniyetmələrdə 17%.

Mif 2: «Kannabis kəsilmə sindromu yoxdur»

Sübut: DSM-5 (2013) — kəsilmə sindromu rəsmi kateqoriya; qıcıqlanma, yuxu və iştaha pozuntusu müşahidə olunur.

Mif 3: «Tibbi kannabis psixoz riskini azaldır»

Sübut: Marconi 2016 — THC psixoz riskini istifadə səviyyəsindən asılı olaraq artırır: orta istifadədə təxminən 2 dəfə (şans nisbəti — ŞN 1,97), ən ağır istifadəçilərdə təxminən 4 dəfə (OR 3,90); kannabidiol (KBD) üçün ilkin sübut mövcuddur, lakin bu, klinik tövsiyə deyil.

Mif 4: «Kannabis „giriş qapısı“ maddəsi deyil»

Sübut: «giriş qapısı» konsepsiyası mübahisəlidir, lakin ardıcıl istifadə paterni statistik aşkardır; səbəb-nəticə əlaqəsi isə fərqli izah tələb edir.

Mif 5: «Yüksək THC-li kannabis adi kannabisdən daha təhlükəsizdir»

Sübut: THC dozası psixoz, asılılıq, koqnitiv pozuntu riski ilə düz mütənasibdir; «Təsir gücünün tədricən artması» (potency creep) son onilliklərdə müşahidə olunur.

Mif 6: «Sintetik kannabinoidlər („Spice“) təhlükəsizdir»

Sübut: sintetik kannabinoidlər çox güclü, gözlənilməz; kəskin psixoz və ölüm halları qeydə alınıb.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C41 Kannabis istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. ABŞ Narkotiklərə Nəzarət İnstitutu (NIDA). Kannabis üzrə tədqiqat hesabatı. 2020.
4. Deyvis M.L. və b. Müalicə üçün müraciət edən kannabis istifadəçiləri üçün davranış terapiyaları: randomizə olunmuş nəzarətli sınaqların meta-analizi. «Sağlamlıq Peşəkarlarının Qiymətləndirilməsi» (Eval Health Prof). 2015;38(1):94–114.
5. Qrey K.M. və b. Yetkinlərdə kannabis istifadəsi pozuntusu üçün N-asetilsisteinin randomizə olunmuş plasebo-nəzarətli sınağı. «Dərman və Alkoqol Asılılığı» (Drug Alcohol Depend). 2017;177:249–257.
6. Markoni A. və b. «Şizofreniya Bülleteni» (Schizophr Bull). 2016;42(5):1262–1269.
7. Spiqa F., Parkhaus T., Tanq V.M. və b. Kannabis istifadəsi pozuntusu üçün farmakoterapiyalar. «Cochrane Sistematik İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2025;9(9):CD008940.

XBT-11 **6C43**	**6C43 OPİOİDLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **Disorders due to use of opioids**
XBT-10 F11	Opioidlərin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları

XBT-11 **6C43**	**6C43 OPİOİDLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **Disorders due to use of opioids**
DSM-5-TR F11.20	Opioid istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Opioidlərin Qəbulundan Qaynaqlanan Pozuntular (ing. XBT-11: 6C43; DSM-5-TR: F11.20 Opioid Use Disorder, OUD) — opioidlərin (heroin, morfin, oksikodon, fentanil və s.) nəzarəti pozulmuş istifadəsi və ya zərər yaradan istifadə paterni. Tibbi və cinayət xarakterli nəticələrlə bağlı yüksək ölüm göstəricisi (dozanın aşılması).

2. Tarixçə

- Dole V.P., Nyswander M. (1965) — metadon saxlama terapiyası ilkin tədqiqatları.
- 2010+ ABŞ-da opioid epidemiyası — resept üzrə yazılan opioidlərdən başlayan, fentanilin dozanın aşılması böhranına qədər.
- WHO, SAMHSA, NICE — opioid aqonist saxlama terapiyası (OAT) qızıl standart.

3. Epidemiologiya

- Dünya: 40 mln+ pasiyent (UNODC); ABŞ-da ildə 80 000-dən çox dozanın aşılması nəticəsində ölüm.
- Cins: kişilərdə 2 dəfə yüksək.
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, PTSP, ŞPP, HIV/HCV, kardial.
- Mortalite: opioid istifadəsi pozuntusu olan pasiyentlərdə əhali (populyasiya) ilə müqayisədə 10–20 dəfə yüksək.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 50%.

- Neyrobioloji — μ-opioid reseptor sisteminin dopaminergik mükafat dövrünə təsiri.
- Mühit — resept opioidlərinin əlçatanlığı, sosial-ekonomik faktorlar.
- Ağrı sindromları — resept üzrə müalicədən asılılığa keçid.

5. Klinik təzahürlər

- Asılılıq sindromu (AUD ilə eyni meyarlar).
- İntoksikasiya — mioz, sedasiya, respirator depressiya, hipotenziya, koma.
- Doza aşılması — respirator depressiya əsas ölüm səbəbidir; nalokson antidot.
- Kəsilmə — başlanğıc 8–24 saat (qısa təsirli), 36–72 saat (uzun təsirli metadon); rinoreya, lakrimasiya, midriaz, narahatlıq, taxikardiya, qarın krampları, ishal, tük qabartısı (piloereksiya).
- Kəsilmə böyüklərdə həyat üçün təhlükəli deyil (alkohol/sedativdən fərqli), lakin yeni doğulmuşda ağır (ing. NAS — Neonatal Abstinence Syndrome).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR: AİP ilə eyni 11 meyardan ibarət struktur (yüngül/orta/ağır). XBT-11 DSM-5-TR-in vahid meyar sistemindən fərqli olaraq üç ayrı kateqoriya tətbiq edir: zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılıq. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay; asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 3 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- SAMHSA TIP 63 — Opioid istifadəsi pozuntusunun dərman müalicəsi.
- NICE CG52 — opioid asılılığı.
- WHO mhGAP.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Toksikoloji skrininq (sidik).
3. HIV, HCV, sifilis, hamiləlik testi.
4. Komorbidlik və dozanın aşılması tarixçəsi.
5. COWS (ing. Clinical Opiate Withdrawal Scale) — kəsilmə şiddəti.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Xronik ağrı (asılılıq olmadan)	Tibbi göstəriş; istifadə paterni.
Başqa maddə istifadəsi (sedativ, alkohol)	Toksikoloji.
Funksional mədə-bağırsaq pozuntuları və tük qabartısı (piloereksiya) — kəsilmədən fərqləndirmə	Tibbi qiymətləndirmə.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Toksikoloji skrininq.
- COWS şkalası.
- HIV, HCV, HBV, sifilis.
- EKG (metadon başlanmazdan əvvəl — QTc intervalı).
- Hamiləlik testi.

8. Müalicə

8.1 OAT — opioid aqonist saxlama terapiyası (qızıl standart)

1. Metadon (saxlama klinikasında, gündəlik nəzarət altında) — tam μ-aqonist; 60–120 mq/gün; uzun yarımömürlüdür; QTc monitorinqi tələb olunur.
2. Buprenorfin/nalokson (Suboxone) — parsial μ-aqonist + nalokson; ofis-əsaslı reseptlə; aşağı doza aşılması potensialı; induksiya yüngül kəsilmə vəziyyətində başlanır.
3. OAT mortaliteti (Sordo L. və b. BMJ 2017;357:j1550 meta-analiz) və HIV-in ötürülməsini (MacArthur G.J. və b. BMJ 2012 meta-analiz) əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
4. OAT mortalitetin azaldılmasında psixososial müdaxilədən üstündür; lakin psixososial müdaxilə (MI, KDT, kontingens idarəetmə, həmyaşıd dəstəyi, 12 addımlıq proqram — bax: «Müalicə metodikaları») ilə kombinasiya optimaldır.

8.2 Antaqonistik müalicə

- Naltrekson (oral 50 mq və ya IM Vivitrol 380 mq aylıq) — başlanmazdan 7–10 gün əvvəl pasiyent abstinent olmalıdır; motivasiyalı pasiyentlər və ya formal saxlama proqramları olmadıqda tətbiq edilir.

8.3 Dozanın aşılmasının idarə edilməsi

- Nalokson — IM/IN; geniş yayılmış; naloksonun evə verilməsi proqramları (icma əsaslı) ölümü azaldır.

8.4 Hamiləlikdə

- Metadon və ya buprenorfin — OAT hamiləlikdə davam etdirilir; detoksifikasiya əks-göstərişdir (yenidən asılılıq və hamiləliyin itirilməsi riski).
- NAS (neonatal abstinensiya sindromu) müdaxiləsi yeni doğulmuşda — morfin və ya metadon.

8.5 Müalicə metodikaları

1. Metadon Saxlama Terapiyası (ing. Methadone Maintenance Therapy, MMT) — Dole-Nyswander modeli; klinika şəraitində.
2. Buprenorfin/Nalokson — Ofis-əsaslı; «Suboxone induksiyası» protokolu; maksimal effekt sayəsində daha az doza aşılması potensialı.
3. Nalokson Evə-Verilən (Take-Home) Proqramı — İcma əsaslı; ailəyə antidot təlimi.
4. Klinik Opioid Abstinensiya Şkalası (ing. Clinical Opiate Withdrawal Scale, COWS) 11 maddədən ibarətdir; induksiyada vacibdir.
5. Naltrekson IM (Vivitrol) — Aylıq; abstinent pasiyentdə.

8.6 Mənbələr arasında fərqlər

- SAMHSA TIP 63 (2021).
- NICE CG52 (opioid detoksifikasiyası) və CG51 (psixososial müdaxilələr).
- WHO — OAT qızıl standart, abstinensiya-yönəlmiş yanaşmadan üstün.

9. Proqnoz

- OAT ilə uzunmüddətli stabilizasiya və mortalitet azalması.
- Komorbidlik müdaxiləsi vacib.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «OAT (metadon, buprenorfin) bir narkomaniyanı başqası ilə əvəz edir»

Sübut: OAT tibbi müalicədir — mortaliteti, HIV-in ötürülməsini, cinayətkarlığı və sosial pozulmaları əhəmiyyətli dərəcədə azaldır; əxlaqi mülahizələrə söykənən anti-OAT mövqe sübuta əsaslanmır. WHO, SAMHSA, NICE — OAT qızıl standart.

Mif 2: «Detoksifikasiya kifayətdir, OAT lazım deyil»

Sübut: tək detoks 90%+ residiv, doza aşılmasından ölüm halları detoksdan dərhal sonra ən yüksək (tolerans itkisi). OAT mortaliteti 50%-dən çox azaldır.

Mif 3: «Ultra sürətli opioid detoksifikasiyası (UROD) effektivdir»

Sübut: UROD ölüm halları və ciddi yan təsirlərlə müşayiət olunur; effekt sübutu yoxdur; SAMHSA və NICE tövsiyə etmir.

Mif 4: «Hamilə qadında detoks lazımdır»

Sübut: hamiləlikdə detoks əks-göstərişdir; OAT (metadon və ya buprenorfin) saxlanılır.

Mif 5: «İboqain və ya ayahuaska opioid asılılığını sağaldır»

Sübut: sübutlu deyil; ibogaine kardial aritmiya və ölüm halları ilə müşayiət olunur (FDA xəbərdarlığı); standart praktikada deyil.

Mif 6: «Naltrekson opioid istifadəsi pozuntusu (OİP) üçün birinci sıra dərmanıdır»

Sübut: SAMHSA TIP 63 — mortalitetin azaldılmasında metadon və buprenorfin daha effektivdir; naltrekson motivasiyalı abstinent pasiyentdə.

Mif 7: «Naloksonun evə verilməsi proqramları istifadəni təşviq edir»

Sübut: Walley A.Y. və b. BMJ 2013 — icma nalokson proqramları doza aşılmasından ölümləri əhəmiyyətli azaldır; istifadəni artırmır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C43 Opioid istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.

3. ABŞ Maddə Aludəçiliyi və Ruhi Sağlamlıq Xidmətləri Administrasiyası (SAMHSA). TIP 63: Opioid istifadəsi pozuntusu üçün dərmanlar. 2021.
4. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) CG52; Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) CG51.
5. MacArthur Q.C. və b. Opioid əvəzedici müalicə və inyeksiya edən şəxslərdə HİV yoluxması. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2012;345:e5945.
6. Sordo L., Barrio Q., Bravo M.C. və b. Opioid əvəzedici müalicə zamanı və sonrasında ölüm riski: kohort tədqiqatlarının sistematik icmalı və meta-analizi. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2017;357:j1550.
7. Volley A.Y. və b. Opioid həddindən artıq doza hallarının tezliyi və dozadan artıq istifadə təhsili ilə burun naloksonunun paylanmasının tətbiqi. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2013;346:f174.

XBT-11 **6C44**	**6C44 SEDATİV, HİPNOTİK VƏ YA ANKSİOLİTİK MADDƏLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **(ing. Disorders due to use of sedative, hypnotic or anxiolytic drugs)**
XBT-10 F13	Sedativ və ya hipnotik maddələrin istifadəsindən yaranan psixi və davranış pozuntuları
DSM-5-TR F13.20	Sedativ, hipnotik və ya anksiolitik istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Sakitləşdirici, Hipnotik və ya Anksiyolitiklərin Qəbulundan Qaynaqlanan Pozuntular (ing. XBT-11: 6C44; DSM-5-TR: F13.20 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Use Disorder) — benzodiazepinlər, z-dərmanları (zolpidem, zopiklon), barbituratlar və digər anksiolitiklərin nəzarəti pozulmuş istifadəsi. Klinik təcrübədə tez-tez tibbi reseptli başlanğıc; «İatrogen asılılıq» tez-tez rast gəlinir.

2. Tarixçə

- 1960-cı illər — benzodiazepinlərin klinik tətbiqi (xlordiazepoksid 1960, diazepam 1963).
- 1980-ci illər — uzunmüddətli istifadənin asılılıq potensialının tanınması.
- NICE və APA — qısamüddətli istifadə tövsiyəsi (2–4 həftə).

3. Epidemiologiya

- Benzodiazepinlərin uzunmüddətli istifadəsi yaşlılarda 10–20% təşkil edir; problemin aşkarlanması azdır.
- Cins: qadınlarda reseptlərin sayı daha yüksəkdir.
- Komorbidlik: alkohol və opioid istifadəsi (təhlükəli kombinasiya — doza aşılması riski).

4. Etiologiya və patogenez

- İatrogen — uzunmüddətli reseptlər.
- GABA-A reseptor sisteminə uyğunlaşma — tolerans və kəsilmə.
- Narahatlıq və yuxu pozuntusu olan pasiyentlərdə özünü-müalicə paterni müşahidə olunur.

5. Klinik təzahürlər

- Asılılıq sindromu — nəzarət itkisi, tolerans, kəsilmə.
- İntoksikasiya — sedasiya, ataksiya, dizartria, dezinhibisiya, anterograd amneziya.
- Doza aşılması — opioidlərlə birlikdə həyat üçün təhlükəli respirator depressiya.
- Kəsilmə — həyat təhlükəli (alkohol kimi): tremor, narahatlıq, taxikardiya, hipertenziya; ağır halda tutmalar və titrəmə deliriyasına (ing. delirium tremens) bənzər sindrom.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR — 11 meyar (alkoqol istifadəsi pozuntusu — AİP strukturu). XBT-11, DSM-5-TR-in vahid şkalasından fərqli olaraq, üç ayrı kateqoriya işlədir: zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılıq. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay;

asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 3 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE — benzodiazepin resepti 2–4 həftə; uzunmüddətli istifadə yenidən qiymətləndirilməlidir.
- Beers meyarları — yaşlılarda benzodiazepinlərdən çəkinmək tövsiyə olunur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və resept tarixçəsi.
2. Toksikoloji skrininq.
3. Komorbid alkohol və opioid istifadəsi (xüsusilə doza aşılması riski).
4. Klinik müayinə — kəsilmə əlamətləri.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Həqiqi narahatlıq pozuntusu	Komorbid; benzodiazepin istifadəsi simptomatikdir.
Alkohol istifadəsi	Komorbidlik tez-tez.
Opioid istifadəsi	Komorbid; doza aşılması riski yüksək.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Toksikoloji skrininq.
- Vital göstəricilər (kəsilmə).

8. Müalicə

1. Tədricən kəsmə (taper) qızıl standart: uzun təsirli benzodiazepinə (diazepam) ekvivalent doza çevirmə, sonra həftədə 10–25% azaltma; ümumi 6–12 həftə (bəzən aylar). Sürətli kəsmə həyat təhlükəlidir.
2. Xəstəxanaya yerləşdirmə — ağır kəsilmə və ya komorbid maddə istifadəsi.
3. Psixososial müdaxilə — KDT narahatlıq və ya yuxu pozuntusu üçün; bu farmakoterapiyaya ehtiyacı azaldır.
4. Komorbid pozuntuların müalicəsi (narahatlıq, depressiya, yuxu).
5. Resept idarəsi — ilkin tibbi yardım səviyyəsində.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Ashton təlimatı üzrə tədricən kəsmə — diazepama ekvivalent dozaya keçirmə, sonra tədricən azaltma; ailə dəstəyi.
2. KDT — narahatlıq və yuxu pozuntusu üçün — Bz istifadəsinə alternativ; KDT-I yuxu üçün.
3. Saxlama dövründə toksikoloji izləmə aparılır.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE, Britaniya Milli Formulyarı (BNF) — tədricən kəsmə protokolları.
- Ashton Manual — Heather Ashton (C.H. Ashton) tərəfindən praktiki klinik bələdçi; 1999-cu il nəşri, 2002-ci ildə yenilənib.

9. Proqnoz

- Tədricən taper və KDT ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Yaşlılarda kəsmə həm tibbi, həm də psixoloji cəhətdən çətindir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Benzodiazepinlər həyat boyu təhlükəsiz alına bilər»

Sübut: uzunmüddətli istifadə — tolerans, asılılıq, koqnitiv pozuntu, yıxılma riski (yaşlılarda). NICE — qısamüddətli istifadə.

Mif 2: «Sürətli kəsmək təhlükəsizdir»

Sübut: sürətli kəsmə tutma və ölüm riski ilə müşayiət olunur; tədricən taper kritik.

Mif 3: «Z-droqlar (zolpidem) asılılıq yaratmır»

Sübut: z-droqlar da asılılıq yaradır; AAFP və NICE qısamüddətli istifadə tövsiyə edir.

Mif 4: «Benzodiazepin + opioid təhlükəsizdir»

Sübut: FDA-nın qara çərçivə (black box) xəbərdarlığı — bu kombinasiya respirator depressiya və ölüm riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Mif 5: «Detoksifikasiya yetərlidir»

Sübut: kəsmədən sonra alternativ müalicə (KDT, narahatlıq idarəsi) tələb olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C44 Sedativ, hipnotik və anksiolitik istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Qısa Arayış Bələdçisi. Benzodiazepinlər.
4. Eşton C.H. Benzodiazepinlər: Necə işləyirlər və necə çəkilməli (Eşton Təlimatı). 2002.
5. ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA). Dərman Təhlükəsizliyi Bildirişi. Benzodiazepinlərlə birləşdirilmiş opioid ağrı və ya öskürək dərmanları: ciddi yan təsirlər. 2016.

XBT-11 **6C45**	**6C45 KOKAİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **(ing. Disorders due to use of cocaine)**
XBT-10 F14	Kokainin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları
DSM-5-TR F14.20	Stimulyant (kokain) istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Kokain Qəbulundan Qaynaqlanan Pozuntular (XBT-11: 6C45; DSM-5-TR: F14.20) — kokainin kontrolu pozulmuş istifadəsi və ya zərər yaradan istifadəsi. İntoksikasiya, kəsilmə, zərərli istifadə paterni, asılılıq, induksiyalı psixotik və əhval pozuntuları əhatə edir.

2. Tarixçə

- Koka yarpaqları And dağlarında minilliklər boyu istifadə olunur.
- Niemann A. (1860) — kokainin təcrid edilməsi.
- Freud (1884) — «Über Coca» — sonradan klinik təsirini tənqid etmişdir.
- 1970–80-ci illər — «krak» epidemiyası ABŞ-da.

3. Epidemiologiya

- Dünyada illik istifadəçilərin sayı 21 milyondur (UNODC).
- Cins: kişilərdə 2 dəfə yüksəkdir.
- Komorbidlik: alkohol, opioid, TDP, ŞPP, psixoz, kardiovaskulyar mortalitet.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsi meyillilik 40–50% təşkil edir.
- Neyrobioloji — dopaminin geri götürülməsinin bloklanması nəticəsində mezolimbik mükafat sisteminin aktivləşməsi; tolerans və «down-regulation».
- Sosial-mədəni — həmyaşıd təsiri, əlçatanlıq, sosial-iqtisadi amillər.

5. Klinik təzahürlər

- Asılılıq sindromu (DSM-5-TR meyarları).
- İntoksikasiya — eyforiya, hipervigilentlik, midriaz, taxikardiya, hipertenziya, hipertermiya; ağır halda paranoid sayıqlama, hallüsinasiya, agitasiya, miokard infarkt, insult, tutmalar.
- Kəsilmə — «crash» — depressiv əhval, anhedoniya, yorğunluq, hipersomniya, iştaha artımı, güclü kreyvinq (craving); intihar riski yüksək.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR 11 meyar (AUD strukturu). XBT-11 DSM-5-TR-in vahid şkalasından fərqli olaraq üç ayrıca kateqoriya işlədir: zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılıq. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay; asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 3 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- SAMHSA TIP 33 — stimulyant istifadəsi.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + toksikoloji.
2. EKQ, troponin (xüsusilə sinə ağrısı).
3. HIV, HCV, sifilis.

4. Komorbidlik və intihar riski (kəsilmə dövründə yüksək).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Amfetamin/stimulyant (6C46)	Toksikoloji müayinəsi ilə ayırd edilir.
Manik epizod	Maddə tarixçəsi və zaman bağlılığı.
Psixoz (kokain induksiyalı və ya primer)	Maddə eliminasiyasından sonra remissiya.
Hipertiroid, feoxromositoma	Endokrin testlər.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Toksikoloji.
- EKG, troponin, kardial qiymətləndirmə.
- HIV, HCV.
- C-SSRS.

8. Müalicə

1. Psixososial — birinci sıra:
    - Kontingens idarəetmə — sübut bazası ən güclü (Petry N.M. icmalları).
    - KDT;
    - MI;
    - İcma Dəstəyi Yanaşması (ing. Community Reinforcement Approach — CRA).
2. Farmakoterapiya — spesifik FDA təsdiqli preparat yoxdur. Off-label tədqiqatlar — disulfiram, modafinil, topiramat — qarışıq nəticələr.
3. Komorbidlik müalicəsi.
4. Kəskin intoksikasiya — benzodiazepin (lorazepam); kardial monitorinq; antipsixotik psixoz halında.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Kontingensiya İdarəsi (ing. Contingency Management) — Petri (Petry N.M.), Higgins (Higgins S.) — Negatif toksikoloji testlər üçün kupon/mükafat; sübut bazası kokain üçün ən güclü.

2. KDT və İcma Gücləndirmə Yanaşması (ing. CRA — Community Reinforcement Approach) — Tətikləyicilərin idarəsi, alternativ mükafat fəaliyyətləri.
3. Motivasiya müsahibəsi (MM) — davranış dəyişikliyinə motivasiya.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- SAMHSA TIP 33 — kontingens idarəetməni əsas yanaşma hesab edir.
- NIDA — kokainə spesifik farmakoterapiya yoxdur.

9. Proqnoz

- Kontingens idarəetmə ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Komorbid maddə istifadəsi və psixiatrik pozuntu pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Kokain „rekreasion“ maddədir, asılılıq yaratmır»

Sübut: kokain yüksək asılılıq potensialına malikdir; kardiovaskulyar mortalitet, psixoz, sosial pozulma.

Mif 2: «Kokain üçün FDA təsdiqli müalicə mövcuddur»

Sübut: hələ yoxdur; psixososial müdaxilə birinci sıra.

Mif 3: «Kokainin kəsilmə dövrü («kraş») təhlükəsizdir və müalicə tələb etmir»

Sübut: kəsilmə dövründə intihar riski yüksək; aktiv izləmə tələb olunur.

Mif 4: «Crack və koka tozu fərqli pozuntulardır»

Sübut: eyni maddə (kokain); yeridilmə yolu (tüstü ilə və ya intranazal) farmakokinetikanı və asılılığın formalaşma sürətini dəyişir.

Mif 5: «Hamiləlikdə «krak körpəsi» konsepsiyası — uşaqlarda davamlı zərər»

Sübut: son icmallar — prenatal kokainə məruz qalmanın uzunmüddətli təsirləri əvvəlcə hesab edilənlərdən az; sosial-iqtisadi amillər daha güclü təsir göstərir (Frank D.A. JAMA 2001 icmal).

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C45 Kokain istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. ABŞ Maddə Aludəçiliyi və Ruhi Sağlamlıq Xidmətləri Administrasiyası (SAMHSA). TIP 33: Stimulyator istifadəsi pozuntularının müalicəsi. 2021 yenilənməsi.
4. ABŞ Narkotiklərə Nəzarət İnstitutu (NIDA). Tədqiqat hesabatı: Kokain. 2016.
5. Petry N.M., Alessi S.M., Olmsted T.A. Maddə istifadəsi pozuntularının müalicəsində kontingent idarəetmə. «Asılılıq Davranışları Psixologiyası» (Psychol Addict Behav). 2017;31(8):897–906.
6. Frank D.A. və b. Doğuşdan əvvəl kokainə məruz qalmadan sonra erkən uşaqlıqda böyümə, inkişaf və davranış. «JAMA». 2001;285(12):1613–1625.
7. Hiqqins S.T., Budney A.C., Bikel V.K. və b. Stimullar kokain asılılığının ambulator davranış müalicəsində nəticəni yaxşılaşdırır. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 1994;51(7):568–576.

XBT-11 **6C46**	**6C46 AMFETAMİN, METAMFETAMİN VƏ YA METKATİNON DA DAXİL OLMAQLA STİMULYATOR MADDƏLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **(ing. Disorders due to use of stimulants including amphetamines, methamphetamine or methcathinone)**
XBT-10 F15	Digər stimulyatorların (kofein də daxil olmaqla) qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları

XBT-11 **6C46**	**6C46 AMFETAMİN, METAMFETAMİN VƏ YA METKATİNON DA DAXİL OLMAQLA STİMULYATOR MADDƏLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **(ing. Disorders due to use of stimulants including amphetamines, methamphetamine or methcathinone)**
DSM-5-TR F15.20	Stimulyant (amfetamin tipli) istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Stimullaşdırıcı Maddələrin Qəbulundan Qaynaqlanan Pozuntular (ing. XBT-11: 6C46; DSM-5-TR: F15.20 Stimulant Use Disorder) — amfetamin, metamfetamin, metkatinon və digər stimulyatorların istifadəsi nəticəsində inkişaf edən pozuntular. XBT-11-də ayrıca kodlanır: kokain (6C45), sintetik katinonlar, mefedron da daxil olmaqla (6C47), kofein (6C48), metilendioksimetamfetamin (MDMA) və oxşar maddələr, metilendioksiamfetamin (MDA) daxil olmaqla (6C4C).

2. Tarixçə

- Amfetamin ilk dəfə Edeleano L. tərəfindən 1887-ci ildə sintez edilmişdir; İkinci Dünya müharibəsində geniş istifadə olunmuşdur.
- 1950–60-cı illər — aptek-resept epidemiyası.
- Metamfetamin epidemiyası 1990-cı illərdən.
- «Hamam duzları» (Bath salts, sintetik katinonlar) 2010-cu ildən sonrakı epidemiya. «Krokodil» (dezomorfin) opioiddir və XBT-11-də opioidlərdən istifadə nəticəsində yaranan pozuntular qrupuna (6C43) aid edilir.

3. Epidemiologiya

- Dünyada istifadəçilərin sayı: amfetamin — 30 milyondan çox (UNODC).
- Cins: kişilərdə yüksək.
- Komorbidlik: psixoz, TDP, narahatlıq, kardiovaskulyar, dəri zədələri (özünə qaşıma, «metamfetamin ağzı»).

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 40–50%.
- Neyrobioloji — dopamin və noradrenalin sərbəstləşməsi və geri-götürülmənin blokası; ağır neyrotoksiklik (xüsusilə metamfetamin — dopamin neyronlarına).

5. Klinik təzahürlər

- İntoksikasiya — eyforiya, hipervigilentlik, midriaz, taxikardiya, hipertenziya, hipertermiya; ağır halda paranoid psixoz, agitasiya, miokard infarkt, insult, tutmalar, rabdomioliz.
- Kəsilmə — «crash» — depressiv əhval, anhedoniya, yorğunluq, hipersomniya, iştaha, güclü kreyvinq (craving); intihar riski yüksək.
- Xroniki istifadə — psixoz (paranoid sayıqlamalar, hallüsinasiyalar), koqnitiv çatışmazlıq, «metamfetamin ağzı» (diş çürüməsi), dəri qaşıma.
- MDMA (6C4C) — hiponatriemiya, hipertermiya, serotonin sindromu, neyrotoksiklik.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR 11 meyar (AUD strukturu). XBT-11 DSM-5-TR-in vahid şkalasından fərqli olaraq üç ayrıca kateqoriya işlədir: zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılıq. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay; asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 3 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- SAMHSA TIP 33 — stimulyant istifadəsi.
- NIDA — metamfetamin tədqiqat hesabatları.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Toksikoloji.
3. EKG, troponin.
4. Komorbidlik (psixoz, TDP, kardiovaskulyar).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Kokain (6C45)	Toksikoloji.
Manik epizod	Maddə zaman bağlılığı.
Şizofreniya	Maddə eliminasiyasından sonra remissiya yox.
Hipertiroid, feoxromositoma	Endokrin.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Toksikoloji.
- EKG, troponin, KFK (kreatinfosfokinaza) — rabdomioliz.
- Diş və dəri müayinəsi.
- C-SSRS.

8. Müalicə

1. Psixososial — birinci sıra:
    - Kontingens idarəetmə;
    - KDT;
    - MI;
    - Matriks Modeli — amfetamin asılılığı üçün standartlaşdırılmış kompleks proqram.
2. Farmakoterapiya — spesifik FDA təsdiqli preparat yoxdur; off-label: mirtazapin, naltrekson və bupropion (Trivedi M.H. NEJM 2021 — ADAPT-2 sınağında metamfetamin üçün kombinasiya — zəif təsir).
3. Kəskin intoksikasiya — benzodiazepin agitasiya üçün; antipsixotik psixozda.
4. Komorbid psixoz — paralel müalicə.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Matriks Modeli (ing. Matrix Model) — 16 həftəlik strukturlaşdırılmış proqram — KDT, ailə təhsili, 12 addımlı proqram və fərdi məsləhətləşmə. Sübut bazası amfetamin və metamfetamin asılılığı üçün ən güclüdür.
2. Kontingensiya İdarəsi (ing. Contingency Management) — Negatif test üçün mükafat.
3. Naltrekson və bupropion (ADAPT-2) — metamfetamin asılılığında ilkin randomizə edilmiş klinik sınaq sübutu; off-label.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- SAMHSA TIP 33.
- NIDA.
- Trivedi M.H. və b. NEJM 2021 — naltrekson + bupropion metamfetamin asılılığında ilkin sübut bazası.

9. Proqnoz

- Multimodal yanaşma ilə remissiya 30–50%.
- Komorbid psixoz pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Metamfetamin „Spice“dən və ya başqa «dizayner dərman»lardan təhlükəsizdir»

Sübut: metamfetamin yüksək neyrotoksiklik, psixoz, mortalitet yaradır.

Mif 2: «MDMA „təmiz“ maddə kimi təhlükəsizdir»

Sübut: MDMA üçün hipertermiya, hiponatriemiya, serotonin sindromu; «təmiz» maddə tipik olaraq qarışıqdır (sintetik katinonlar, fentanil).

Mif 3: «Detoksifikasiya stimulyant asılılığı üçün yetərlidir»

Sübut: kontingens idarəetmə və KDT əsas; tək detoks 90%+ residiv.

Mif 4: «Antidepresan stimulyant asılılığını sağaldır»

Sübut: təkcə antidepresan təsirsizdir; ADAPT-2 kombinasiya üçün ilkin sübut verir.

Mif 5: «Stimulyant istifadəçilər „məhsuldardır“, müdaxilə tələb etmir»

Sübut: qısamüddətli məhsuldarlığın artması təəssüratı; uzunmüddətli koqnitiv, psixiatrik, kardial komplikasiyalar.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C46 Stimulyator istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. ABŞ Maddə Aludəçiliyi və Ruhi Sağlamlıq Xidmətləri Administrasiyası (SAMHSA). TIP 33. 2021.
4. ABŞ Narkotiklərə Nəzarət İnstitutu (NIDA). Metamfetamin üzrə tədqiqat hesabatı. 2019.
5. Trivedi M.H. və b. Bupropion və naltrekson metamfetamin istifadəsi pozuntusunda. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2021;384(2):140–153.
6. Rawson R.A. və b. Matrix Modeli. ABŞ Maddə Aludəçiliyi və Ruhi Sağlamlıq Xidmətləri Administrasiyası (SAMHSA).

XBT-11 **6C49**	**6C49 HALLÜSİNOGENLƏRİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **Disorders due to use of hallucinogens**
XBT-10 F16	Hallüsinogen maddələrin qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları
DSM-5-TR F16.20	Digər hallüsinogen istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Hallüsinogenlərin qəbulundan qaynaqlanan pozuntular (ing. XBT-11: 6C49; DSM-5-TR: F16.20 Hallucinogen Use Disorder) — LSD, psilosibin, meskalin, DMT, ayahuasca və oxşar maddələrin istifadəsi ilə bağlı pozuntular. Dissosiativ maddələr — ketamin və fensiklidin (PCP) — XBT-11-də ayrıca kodlanır (6C4D).

2. Tarixçə

- Hofmann A. (1943) — LSD-nin hallüsinogen təsirinin təsadüfən aşkarlanması.
- 1950–60-cı illər — klinik tədqiqatlar (depressiya, şizofreniya).
- 1970 — ABŞ-da Təsirli Maddələr haqqında Qanunla I siyahı (Schedule I) statusu müəyyən edilmişdir.
- 2020-ci illər — psilosibin və ketamin «psixodelik terapiya» tədqiqatların canlanması.

3. Epidemiologiya

- Asılılıq nisbətən nadir (digər maddələrdən fərqli); tipik istifadə episodik.
- Hallüsinogenlə əlaqəli davamlı persepsiya pozuntusu (HPPD) — fleşbekə bənzər təcrübələr.

4. Etiologiya və patogenez

- Serotoninergik (5-HT2A) və ya NMDA (ketamin, PCP) reseptorlarına təsir edir.
- Mühit, həmyaşıd mühiti, eksperimentasiya.

5. Klinik təzahürlər

- İntoksikasiya — vizual hallüsinasiyalar, sinesteziya, zaman pozuntusu, depersonalizasiya, derealizasiya, «pis təcrübə» (panik hücumu, paranoyya).
- Ağır halda — psixoz, ölümcül qəzalar.
- «Davamlı persepsiya pozuntusu» (HPPD) — istifadədən sonra davam edən vizual fenomenlər (flashback).
- Ketamin — dissosiasiya, «K-hole»; xroniki istifadə — sidik kisəsi sindromu.
- PCP — PCP — aqressiv davranış, analjeziya və dezorqanizasiya.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR 11 meyar; HPPD ayrı diaqnoz (DSM-5). XBT-11 DSM-5-TR-in vahid şkalasından fərqli olaraq üç ayrı kateqoriya tətbiq edir: zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılıq. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay; asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 3 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NIDA, SAMHSA.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Toksikoloji analiz (liserg turşusu dietilamidi — LSD standart panellərə daxil edilmir).
3. Komorbid psixoz, narahatlıq, TDP.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Şizofreniya	Davamlı simptomlar.
Depersonalizasiya-derealizasiya pozuntusu (6B66)	Reallığın qiymətləndirilməsi saxlanılır.
Qıcolma	elektroensefaloqrafiya (EEQ).

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Toksikoloji.
- Komorbidlik şkalaları.

8. Müalicə

1. Kəskin intoksikasiya («ağır təcrübə»; ing. bad trip) — sakit mühit, benzodiazepin (lorazepam); antipsixotik (haloperidol) yalnız ağır psixotik halda; ehtiyat.
2. Asılılıq nadir; psixososial müdaxilə (MI, KDT).
3. HPPD — antipsixotiklər adətən təsirsizdir; klonazepam bəzi pasiyentlərdə kömək edir; uzunmüddətli izləmə.
4. psilosibin və ketaminin terapevtik tədqiqatları (refrakter TDP, PTSP) — tədqiqat protokollarında nəzarət altında istifadə; standart klinik praktikada hələ təsdiq olunmuş protokollar məhduddur (FDA esketamin Spravato istisna).

8.1 Müalicə metodikaları

1. «Ağır təcrübə» (ing. bad trip) idarəsi sakit mühit, təskinlik, benzodiazepin lazım olduqda.

2. HPPD üçün clonazepam — Off-label; sübut bazası kiçik.
3. Psixodelik dəstəkli terapiya (ing. psychedelic-assisted therapy — tədqiqat mərhələsində) — psilosibin və psixoterapiya, ketamin + psixoterapiya; klinik tədqiqat protokollarında.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NIDA — psixodelik tədqiqat renessansı; klinik tövsiyə hələ vaxtsızdır.

9. Proqnoz

- Əksər istifadəçilərdə asılılıq inkişaf etmir.
- Ağır psixotik və ya HPPD komplikasiyalı pasiyentlərdə xronik gediş.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Hallüsinogenlər asılılıq yaratmır, tamamilə təhlükəsizdir»

Sübut: fiziki asılılıq nadir, lakin psixoloji asılılıq və ağır psixotik epizodlar mümkündür; HPPD uzunmüddətli komplikasiyadır.

Mif 2: «Psilosibin terapiyası bütün depressiyalar üçün təsdiq edilməmişdir»

Sübut: hələ araşdırma mərhələsindədir; standart klinik praktikaya tam təsdiq olunmamışdır. FDA «Breakthrough Therapy» statusunda, lakin geniş tövsiyə üçün hələ əsas yoxdur.

Mif 3: «Ayahuasca dini ritual üçün təhlükəsizdir»

Sübut: serotonin sindromu (SSGİ ilə qarşılıqlı təsir), psixotik dekompansasiya halları qeyd edilmişdir.

Mif 4: «Ketamin «klub dərmanı»dır (ing. club drug), tibbi istifadəsi var»

Sübut: ketamin anestezik kimi onilliklərdir istifadə olunur; intranazal esketamin (Spravato) FDA 2019 ağır müalicəyə davamlı depressiya üçün təsdiq edilmişdir.

Mif 5: «LSD „flashback“ mifdir»

Sübut: HPPD DSM-5-TR-də rəsmi diaqnozdur; bəzi pasiyentlərdə davamlı vizual pozuntular müşahidə olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C49 Hallüsinojen istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. 2024.

2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. ABŞ Narkotiklərə Nəzarət İnstitutu (NIDA). Hallüsinojenlər haqqında faktlar. 2019.
4. Halpern C.H., Lerner A.Q., Passie T. Hallüsinojenlə əlaqəli davamlı persepsiya pozuntusunun (HPPD) icmalı. «Davranış Nevrologiyasının Aktual Mövzuları» (Curr Top Behav Neurosci). 2018;36:333–360.
5. Karhart-Harris R.L. və b. Depressiya üçün psilosibinin essitalopramla müqayisəsi üzrə sınaq. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2021;384(15):1402–1411.

XBT-11 **6C4A**	**6C4A NİKOTİN QƏBULUNDAN QAYNAQLANAN POZUNTULAR** **Disorders due to use of nicotine**
XBT-10 F17	Tütündən istifadə nəticəsində yaranan psixi və davranış pozuntuları
DSM-5-TR F17.200	Tütün istifadəsi pozuntusu, orta və ya ağır

1. Tərif və nozologiya

Nikotin Qəbulundan Qaynaqlanan Pozuntular (XBT-11: 6C4A; DSM-5-TR: F17.200 — Tütün istifadəsi pozuntusu; ing. Tobacco Use Disorder) — siqaret, tütün məhsulları, e-siqaret və ya digər nikotin maddələrinin nəzarəti pozulmuş istifadəsi. Dünyada qarşısı alına bilən ölümlərin başlıca səbəbidir.

2. Tarixçə

- 1964 — Surgeon General Report (ABŞ) — tütünün xəstəlik səbəbi kimi tanınması.
- DSM-IV — «Nikotin asılılığı»; DSM-5 — «Tütün istifadəsi pozuntusu».
- 2003 — ÜST Tütünə Nəzarət üzrə Çərçivə Konvensiyası (ing. WHO FCTC).
- 2010-cu illərdən — e-siqaret epidemiyası, «EVALI» (elektron siqaret və vape məhsullarının istifadəsi ilə əlaqəli ağciyər zədələnməsi; ing. e-cigarette/vaping product use-associated lung injury).

3. Epidemiologiya

- Dünya: 1,3 milyard istifadəçi; ildə 8 milyondan çox ölüm (ÜST).
- Cins: kişilərdə yüksək (lakin azalmaqdadır); bəzi regionlarda qadınlar arasında artım müşahidə edilir.
- Komorbidlik: TDP, şizofreniya (təxminən 60–80% pasiyent siqaret çəkir), narahatlıq, başqa maddə istifadəsi.
- Tütün — xərçəng, KOAH, kardiovaskulyar, insult, perinatal komplikasiyalar.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 50%.
- Neyrobioloji mexanizm: nikotin α4β2 nikotinik asetilkolin reseptorlarına bağlanır və dopamin vasitəsilə mükafat sistemini aktivləşdirir.
- Sosial-mədəni, peer, marketinq.

5. Klinik təzahürlər

- Asılılıq sindromu.
- Kəsilmə — irritabellik, narahatlıq, konsentrasiya çətinliyi, iştah, yuxu pozulması, depressiv əhval; 24 saatda başlanır, ən yüksək həddə 2–3-cü gündə müşahidə olunur və 2–4 həftə davam edir.
- E-siqaret — nikotin asılılığı + EVALI riski.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR 11 meyar (alkoqol istifadəsi pozuntusu — AİP strukturu). XBT-11 DSM-5-TR-in vahid şkalasından fərqli olaraq üç ayrıca kateqoriya işlədir: zərərli istifadə epizodu, zərərli istifadə paterni və asılılıq. XBT-11 müddət tələbi: zərərli istifadə paterni — epizodik istifadədə ən azı 12 ay, davamlı istifadədə ən azı 1 ay; asılılıq — ən azı 12 ay, davamlı (gündəlik və ya demək olar ki, gündəlik) istifadədə ən azı 3 ay.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- USPSTF — bütün yetkin pasiyentlərdə tütün istifadəsinin skrininqdən keçirilməsi; siqaret çəkənlərə 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) yanaşması.

- NICE NG209 («Tütün: istifadəyə başlamanın qarşısının alınması, tərgitmənin təşviqi və asılılığın müalicəsi», 2021).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (5A).
2. Nikotin asılılığı üzrə Fagerström testi (FTND; ing. Fagerström Test for Nicotine Dependence) tətbiq edilir.
3. CO ekspirator monitorinq (motivasiya).
4. Komorbid kardial və respirator qiymətləndirmə.

6.4 Differensial diaqnostika

Çoxsaylı tütün məhsulları arasında fərqləndirmə; e-siqaret nikotin asılılığı müxtəlif formalarda təqdim edilə bilər.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- FTND.
- CO ekspirator.
- Spirometriya (KOAH skrininqi).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (USPSTF, NICE NG209, APA 2010)

1. 5A modeli (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange).
2. Birinci sıra farmakoterapiya:
    - NƏT — nikotin əvəzedici terapiya (ing. nicotine replacement therapy) (yamaqlar, saqqız, pastil, inhalyator, sprey) — kombinasiya (uzun + qısa təsirli) monoterapiyadan üstündür.
    - Vareniklin (Chantix) — α4β2 parsial agonist; ən təsirli tək preparat (Cahill K. Cochrane 2013 meta-analiz).
    - Bupropion SR (Zyban) — dopaminergik və noradrenergik təsir göstərir.
3. Davranış müdaxiləsi — KDT, MI, telefonla dəstək xidməti («quitline»); intensivlik effekti artırır.
4. Kombinasiya — farmakoterapiya + davranış üstün.
5. E-siqaret tütündən imtina vasitəsi kimi mübahisəli — bəzi tədqiqatlarda effektiv (Hajek P. NEJM 2019), lakin uzunmüddətli təhlükəsizliyi və nikotin asılılığına keçid riski tədqiq edilir; NƏT-ə üstünlük verilir.

6. Komorbidlik (TDP, şizofreniya) — tütündən imtina psixi vəziyyəti pisləşdirmir, əksinə yaxşılaşdırır (Taylor G. BMJ 2014 meta-analiz).

8.2 Müalicə metodikaları

1. 5A modeli — soruş (ing. Ask), məsləhət ver (Advise), qiymətləndir (Assess), kömək et (Assist), izləməni təşkil et (Arrange), Assess (qiymətləndir), Assist (kömək et), Arrange (izləmə təşkil et).
2. Nikotin Əvəzedici Terapiya kombinasiyası (NƏT; ing. nicotine replacement therapy) uzun təsirli yamaq və qısa təsirli (saqqız, pastil) dərman forması.
3. Vareniklin — gündə 2 dəfə 1 mq; 12 həftə standart müddət təşkil edir.
4. Bupropion SR — 150 mq × 2/gün; qıcolma riski.
5. KDT və Motivasiya müsahibəsi (MI) — Tətikləyicilərin idarəsi, motivasiya artımı.
6. Telefonla dəstək xətti («Quitline») — icma əsaslı dəstək; sübut bazası geniş.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- USPSTF 2021 — bütün siqaret çəkənlərə müdaxilə tövsiyə edilir.
- NICE NG209 — komorbid psixiatrik pozuntularda da aktiv müdaxilə.
- Cahill K. və b. Cochrane 2013 — vareniklin ən effektiv.

9. Proqnoz

- Multimodal müdaxilə ilə 6 aylıq abstinensiya 25–35% təşkil edir.
- Tərk uğurla mortalitet və xəstəlik riski əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Tütün asılılıq yaratmır, iradi tərk edilə bilər»

Sübut: nikotin yüksək asılılıq potensialına malikdir; iradi tərk uğursuzluq nisbəti yüksək (üç aydan sonra təxminən 5%); farmakoterapiya effekti 2–3 dəfə artırır.

Mif 2: «Siqaret tərk etdikdə çəki artımı sağlamlığa zərərlidir»

Sübut: ortalama 4–5 kq çəki artımı, lakin tütün istifadəsini davam etdirmənin riski əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir; çəki idarə oluna bilər.

Mif 3: «Vareniklin intihar (suisid) riski yaradır»

Sübut: ilkin FDA xəbərdarlığı sonradan EAGLES trial (Anthenelli R.M. Lancet 2016) ilə yenidən qiymətləndirildi — psixi yan təsirlərin tezliyi placebodan

əhəmiyyətli yüksək deyil; FDA-nın xüsusi xəbərdarlığı (ing. boxed warning) 2016-cı ildə götürülmüşdür.

Mif 4: «Psixiatrik pasiyent tütündən imtina edə bilmir, etməməlidir»

Sübut: Taylor BMJ 2014 — tütündən imtina psixiatrik simptomları yaxşılaşdırır; şizofreniya, TDP pasiyentlərdə imtina effektivdir.

Mif 5: «E-siqaret tütündən təhlükəsizdir»

Sübut: mövcud məlumatlara görə e-siqaret yandırılmış tütündən az zərərlidir, lakin «təhlükəsiz» deyil; EVALI, kardial, respirator riskləri; yeniyetmələr üçün nikotin asılılığına keçid yolu ola bilər.

Mif 6: «Bir dəfə kəsib yenidən başlamaq — deməli, artıq alınmayacaq»

Sübut: əksər siqaret çəkənlər tərk etmək üçün 6–11 cəhd edirlər; hər residiv müvəqqətidir; cəhdləri davam etdirmək planı tövsiyə olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C4A Nikotin istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. ABŞ Preventiv Xidmətlər üzrə İşçi Qrupu (USPSTF). Yetkinlərdə tütün çəkmənin dayandırılması üzrə müdaxilələr. «JAMA». 2021;325(3):265–279.
4. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) NG209. Tütün. 2021.
5. Cahill K., Stevens S., Perera R., Lankaster T. Siqaret çəkmənin dayandırılması üçün farmakoloji müdaxilələr: icmal və şəbəkə meta-analizi. «Cochrane Sistematik İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2013;(5):CD009329.
6. Antenelli R.M. və b. Psixi pozuntusu olan və olmayan siqaret çəkənlərdə vareniklin, bupropion və nikotin plasterinin neyropsixiatrik təhlükəsizliyi və effektivliyi (EAGLES). «Lancet». 2016;387(10037):2507–2520.
7. Teylor Q. və b. Siqaret çəkmənin dayandırılmasından sonra psixi sağlamlıqda dəyişiklik: sistematik icmal və meta-analiz. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2014;348:g1151.
8. Hayek P. və b. Elektron siqaretlərin nikotin əvəzedici terapiya ilə müqayisəsi üzrə randomizə edilmiş sınaq. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2019;380(7):629–637.

XBT-11 **6C50**	**6C50 QUMAR OYNAMA POZUNTUSU** **Gambling disorder**
XBT-10 F63.0	Qumar oyunlarına patoloji meyl
DSM-5-TR F63.0	Qumar oynama pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Qumar oynama pozuntusu (XBT-11: 6C50; XBT-10: F63.0; DSM-5-TR: F63.0) — qumar davranışının davamlı və ya təkrarlanan paterni: nəzarətin pozulması, qumarın digər maraqlar üzərində üstünlük təşkil etməsi və mənfi nəticələrə baxmayaraq davam etməsi. Əhəmiyyətli funksional pozulma yaradır. Oyun oynama pozuntusu (6C51) XBT-11-də ayrı kateqoriyadır — 6C51 Oyun oynama pozuntusu.

2. Tarixçə

- DSM-IV (1994) — DSM-IV (1994) — «Patoloji qumar» impuls nəzarəti pozuntuları qrupuna daxil edilmişdir.
- DSM-5 (2013) — DSM-5 (2013) — «Qumar oynama pozuntusu» maddə istifadəsi və asılılıq pozuntuları kateqoriyasına keçirilmişdir (oxşar neyrobiologiya).
- XBT-11 (2019) — davranış asılılıqları bölməsi genişləndirildi: qumar (6C50) ilə yanaşı oyun oynama pozuntusu (6C51) ayrı kateqoriya kimi əlavə edildi.

3. Epidemiologiya

- Qumar oynama pozuntusunun ömürboyu yayılması: 0,2–5,3% (geniş diapazon).
- Cins: qumar kişilərdə daha yüksək; onlayn qumarda cins fərqi azalır.
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, başqa maddə istifadəsi, DDHP, ŞPP, İntihar riski.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 50–60%.

- Neyrobioloji — mükafat dövrəsinin (dopamin) disrequlyasiyası, maddə istifadəsi pozuntularına bənzərdir.
- Şəxsiyyət — impulsivlik, həyəcan axtarışı (ing. sensation-seeking).

5. Klinik təzahürlər

- Davamlı/təkrarlanan qumar davranışı.
- Kontrol itkisi.
- İş, ailə, sosial, akademik pozulma.
- «İtkilərin dalınca qaçma» (ing. chasing losses) — itkilərin geri qaytarılması cəhdləri.
- Yalan, maliyyə pozulması, gizlətmə davranışı.
- Komorbid TDP və intihar riski yüksək.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

Qumar oynama pozuntusu (DSM-5-TR): 9 simptomdan ən azı 4-ü 12 ay ərzində:

1. Artan miqdarda qumar — tolerans;
2. İrritabellik və ya narahatlıq qumarı azaltmağa cəhd etdikdə — kəsilmə;
3. Azaltma cəhdləri uğursuz;
4. Qumar haqqında məşğuliyyət;
5. Əzab-əziyyət halında qumar;
6. İtkidən sonra «itkilərin dalınca qaçma» (ing. chasing);
7. Yalan;
8. Münasibətlərin və işin itirilməsi;
9. Borcun başqaları tərəfindən ödənilməsindən asılı olma (ing. bailout).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 (6C50) — alt növlər: 6C50.0 əsasən oflayn, 6C50.1 əsasən onlayn, 6C50.Z dəqiqləşdirilməmiş. Diaqnoz üçün adətən ən azı 12 ay tələb olunur; bütün diaqnostik tələblər ödənildikdə və simptomlar ağır olduqda müddət qısaldıla bilər.
- DSM-5-TR — «Gambling Disorder» (F63.0) əsas mətnə daxil edilmiş yeganə davranış asılılığıdır; DSM-5 (2013) onu impuls nəzarəti pozuntularından maddə istifadəsi və asılılıq kateqoriyasına keçirmişdir.

6C51-dən fərqli olaraq, 6C50 tələbləri funksional pozulma ilə yanaşı əhəmiyyətli əziyyəti (ing. distress) də qəbul edir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Cənubi Ouks qumar skrininq şkalası (SOGS) və ya Problemli qumarın şiddəti indeksi (PGSI) tətbiq edilir.
3. Komorbid maddə, TDP, intihar.
4. Maliyyə vəziyyəti qiymətləndirməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Manik epizod (qumar davranışının dezinfibisiyası)	Affektiv simptomlar.
Obsesiv-kompulsiv pozuntu (OKP; kompulsiv yoxlama)	Obsessiyalar əsas əlamətdir.
ŞPP (impulsivlik)	Davamlı model bütün sahələri əhatə edir.
Sosial qumar (problem yox)	Funksional pozulma yoxdur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Komorbidlik şkalaları.
- C-SSRS intihar.

8. Müalicə

1. KDT — birinci xətt terapiyası; tətikləyicilərin idarəsi, davranış aktivasiyası, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma («yaxın buraxma» effekti və «qumarbaz yanılması» (ing. near miss, gambler's fallacy)). Cowlishaw S. Cochrane 2012 meta-analiz.
2. Naltrekson, nalmefen — sübut bazası inkişaf etməkdədir (Qrant C.E. və b. icmalları).
3. SSGİ — komorbid TDP/narahatlıqda.
4. Özünə yardım qrupları (ing. Gamblers Anonymous, Gam-Anon) — köməkçi müalicə.
5. Maliyyə konsultasiyası — qumarda həlledici əhəmiyyət daşıyır.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Qumar üçün KDT koqnitiv distorsiyaların düzəldilməsi, ekspozisiya (tətikləyicilərə cavab azaltma), problemin həlli.
2. Naltrekson təlimatdan kənar (ing. off-label) — həvəsin (ing. craving) azaldılması; 50–150 mq/gün.
3. Özünəyardım qrupları (GA) — 12 addımlı model.

9. Proqnoz

- KDT ilə remissiya 30–50%.
- Komorbid TDP pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Qumar asılılığı „xarakter“ pozuntusudur»

Sübut: DSM-5, XBT-11 — tibbi/davranış pozuntudur; neyrobioloji və genetik yatkınlıq.

Mif 2: «Pasiyent „böyük uduş“la borcdan çıxa bilər»

Sübut: itkinin dalınca qaçmaq (ing. «chasing losses») qumarın diaqnostik əlamətidir; uzun müddətdə itki statistik olaraq qaçılmazdır.

Mif 3: «Yalnız maliyyə dəstəyi kifayətdir»

Sübut: borcun başqaları tərəfindən ödənilməsi (borcun ödənilməsi) asılılığın diaqnostik əlamətidir; psixososial müdaxilə tələb olunur.

Mif 4: «Pasiyent „böyüyəndə keçər“»

Sübut: aktiv müdaxilə tələb olunur; xronikləşmə riski yüksəkdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. 6C50 Qumar pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Koulişou S. və b. Patoloji və problemli qumar üçün psixoloji terapiyalar. «Cochrane Sistematik İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2012;(11):CD008937.

4. Qrant C.E. və b. Qumar pozuntusunun farmakoterapiyası. «Davranış Nevrologiyasının Aktual Mövzuları» (Curr Top Behav Neurosci). 2016;26:135–149.

XBT-11 **6C51**	**6C51 OYUN OYNAMA POZUNTUSU** **Gaming disorder**
XBT-10 —	XBT-10-da uyğun kodu yoxdur
DSM-5-TR —	İnternet oyun pozuntusu (ing. Internet Gaming Disorder; DSM-5-TR III Bölməsi — əlavə tədqiqat üçün vəziyyət)

1. Tərif və nozologiya

Oyun oynama pozuntusunu (XBT-11: 6C51) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı davamlı və ya təkrarlanan oyun davranışı — onlayn və ya oflayn rəqəmsal oyun, yaxud video oyun — paterni kimi müəyyən edilir və üç əsas əlamətlə təzahür edir:

- oyun üzərində kontrolun pozulması (başlanğıc, tezlik, intensivlik, müddət, dayandırılma, kontekst);
- oyuna verilən üstünlüyün artması — oyun digər həyati maraqlar və gündəlik fəaliyyətlərdən üstün tutulur;
- mənfi nəticələr yaranmasına baxmayaraq oyunun davam etdirilməsi və ya artırılması.

Davranış paterni şəxsi, ailəvi, sosial, təhsil, peşə və ya digər mühüm funksional sahələrdə əhəmiyyətli pozulmaya səbəb olacaq qədər ağır olmalıdır. Diqqət yetirin: XBT-11 6C51 üçün əzab-əziyyət meyarı tələb etmir. Pozulma məcburi elementdir və diaqnoza alternativ giriş yolu kimi «nəzərəçarpan distress»in əlavə edilməsi kateqoriyaya öz həddini verən məhz həmin əlaməti aradan qaldırardı. Patern adətən ən azı 12 ay ərzində müşahidə olunur, lakin bütün diaqnostik tələblər ödənildikdə və simptomlar ağır olduqda tələb olunan müddət qısaldıla bilər.

Nozoloji mövqe

6C51 XBT-11-in Asılılıq davranışları ilə bağlı pozuntular (6C50–6C5Z) qrupuna, 6C50 Qumar oynama pozuntusu ilə yanaşı daxildir. Bunlar XBT-11-də ayrı kateqoriyaya malik yeganə iki davranış asılılığıdır; digər namizəd vəziyyətlər üçün

qalıq kodları — 6C5Y (digər dəqiqləşdirilmiş) və 6C5Z (dəqiqləşdirilməmiş) — mövcuddur. XBT-11 72-ci Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası tərəfindən 25 may 2019-cu ildə yekdilliklə qəbul edilmiş və 1 yanvar 2022-ci ildə qüvvəyə minmişdir.

Alt tiplər və istisnalar

- 6C51.0 — Oyun oynama pozuntusu, əsasən onlayn.
- 6C51.1 — Oyun oynama pozuntusu, əsasən oflayn.
- 6C51.Z — Oyun oynama pozuntusu, dəqiqləşdirilməmiş.

6C51 altında sadalanan 6C51 üzrə istisnalara Təhlükəli oyun oynama (QE22), Bipolyar I pozuntu (6A60) və Bipolyar II pozuntu (6A61) aiddir. Buna görə də yalnız manik və ya hipomanik epizod çərçivəsində baş verən həddindən artıq oyun 6C51 kimi kodlaşdırılmır.

Həddaltı kateqoriya QE22

XBT-11-in sağlamlıq vəziyyətinə təsir edən amillərə dair fəslindəki QE22 Təhlükəli oyun oynama, onlayn və ya oflayn oyun paternini bildirir; bu patern şəxs üçün və ya onun ətrafındakılar üçün zərərli fiziki və ya psixi sağlamlıq nəticələri riskini nəzərəçarpacaq dərəcədə artırır, lakin oyun oynama pozuntusunun diaqnostik tələblərinə cavab vermir. Bu kateqoriya ona görə mövcuddur ki, peşəkar diqqət və məsləhət tələb edən hal süni şəkildə pozuntu diaqnozuna uyğunlaşdırılmasın.

Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA) oyunu rəsmi pozuntu kimi tanımayıb: internet oyun pozuntusu (İOP) DSM-5-TR-in III Bölməsində, «Əlavə tədqiqat üçün şərtlər» (ing. Conditions for Further Study) hissəsində qalır və hər iki meyar dəsti bu fəslin 6-cı bölməsində təsvir edilmiş və müqayisə olunmuşdur.

2. Tarixçə

Ön tarix: internet asılılığı (1990-cı illər)

Konseptual sələf DSM-IV-ün patoloji qumar meyarlarını internet istifadəsinə uyğunlaşdıran Young tərəfindən klinik vahid kimi təklif edilmiş «internet asılılığı» olmuşdur (Young, 1998). 1990-cı və 2000-ci illər boyu oyun əsasən bu daha geniş internet asılılığı çərçivəsində öyrənilmişdir — sonradan ölçmə xətasının başlıca mənbəyi kimi müəyyən edilən və bu gün də oyun oynama pozuntusuna dair sistematik icmalları çirkləndirən qarışdırma (Kuss və b., 2017; Colder Carras və b., 2020).

2013 — DSM-5

APA internet oyun pozuntusunu daha çox tədqiqat tələb edən vəziyyət kimi DSM-5-in III Bölməsinə yerləşdirdi və onu rəsmi diaqnoz etməkdən açıq şəkildə imtina etdi. Bu status 2022-ci ildə DSM-5-TR-ə dəyişdirilmədən keçirildi.

2014–2017 — WHO məsləhətləşmələri

ÜST internetin, kompüterlərin, smartfonların və oxşar cihazların həddindən artıq istifadəsinin ictimai səhiyyə nəticələrinə, habelə davranış asılılıqlarına dair bir sıra ekspert görüşləri təşkil etdi. XBT-11 mətnini hazırlayan işçi qrupu belə əsaslandırma verdi: oyun oynama pozuntusunun asılılıq pozuntusundan tələb olunan əsas əlamətləri nümayiş etdirdiyi və artıq müalicəyə müraciət edən insanlar üçün diaqnostik kateqoriyanın zəruri olduğu əsaslandırılırdı (Saunders və b., 2017).

2016–2018 — elmi mübahisə

XBT-11 yekunlaşdırılmazdan əvvəl 26 alim daxil edilməyə qarşı açıq müzakirə məqaləsi dərc edərək tədqiqatın aşağı keyfiyyəti, maddə istifadəsi və qumar meyarlarının tənqidsiz köçürülməsi, mənəvi panika və sağlam oyunçulara zərər barədə xəbərdarlıq etdilər (Aarseth və b., 2017). Qismən üst-üstə düşən qrup daha sonra tədqiqat konstruktundan formal pozuntuya keçid üçün sübutların kifayət etmədiyi barədə arqument irəli sürdü (van Rooij və b., 2018). həkimlər və ictimai səhiyyə tədqiqatçıları eyni jurnalda daxil edilməni müdafiə edərək cavab verdilər (Griffiths və b., 2017; Rumpf və b., 2018). Bu mübahisənin mahiyyəti 10-cu bölmədə şərh olunur.

2018–2019 — formal daxil edilmə

6C51-i ehtiva edən XBT-11 layihəsi 2018-ci ilin iyununda buraxıldı; təsnifat 72-ci Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası tərəfindən 25 may 2019-cu ildə qəbul edildi və 1 yanvar 2022-ci ildə qüvvəyə mindi. 2024-cü ildə WHO XBT-11-in psixi, davranış və neyroinkişaf pozuntuları üçün Klinik təsvirlər və diaqnostik tələblər (ing. Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements, CDDR) sənədini — həkimlərin indi XBT-11 mətni ilə yanaşı istifadə etdikləri əməliyyat təlimatını — dərc etdi.

Siyasət konteksti (qeyri-klinik mənbələr)

Aşağıdakılar hökumət və mətbuat elanlarıdır, klinik sübut deyil; onların klinik təsirinə dair heç bir yüksək keyfiyyətli qiymətləndirmə aşkar edilməmişdir.

- Cənubi Koreya. Shutdown qanunu (yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün gecə vaxtı oyun qadağası) 19 may 2011-ci ildə qəbul edilmiş və 20 noyabr 2011-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Hökumət 25 avqust 2021-ci ildə onun ləğvini

elan etdi; ləğv həmin ilin sonunda qanunvericiliklə rəsmiləşdirildi və qadağa 1 yanvar 2022-ci il tarixindən qüvvədən düşdü.

- Çin. Milli Mətbuat və Nəşriyyat İdarəsinin 30 avqust 2021-ci il tarixli bildirişinə əsasən, 18 yaşınadək istifadəçilər onlayn oyunları yalnız cümə günləri, həftə sonları və rəsmi bayramlarda saat 20:00–21:00 arasında oynaya bilərlər — adi həftədə təxminən üç saat.
- İngiltərə və Uels. NHS-in Oyun pozuntuları üzrə Milli Mərkəzi (ing. NHS National Centre for Gaming Disorders) 2019-cu ilin oktyabrında Londonda açılmışdır.

3. Epidemiologiya

Birləşdirilmiş yayılma

İki iri meta-analiz təxminən 3 faizlik qlobal göstəricidə uzlaşır; metodoloji keyfiyyət nəzərə alındıqda bu rəqəm əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Mənbə	**Baza**	**Qiymət**
Stevens və b., 2021	Dünya üzrə birləşdirilmiş	3,05% (95% ET 2,38–3,91)
Stevens və b., 2021	Ciddi seçmə meyarlarına cavab verən tədqiqatlar	1,96% (95% etibar intervalı (ET) 0,19–17,12)
Kim və b., 2022	61 tədqiqat, 227 665 iştirakçı, 29 ölkə	3,3% (95% CI 2,6–4,0)
Kim və b., 2022	28 reprezentativ seçmə tədqiqatı	2,4% (95% CI 1,7–3,2)
Kim və b., 2022	Nəşr yanlılığı üçün «kəsmə və doldurma» (trim-and-fill) düzəlişindən sonra	1,4% (95% CI 0,9–1,9)
Przybylski və b., 2017	Dörd sorğu, N = 18 932, DSM-5 meyarları	0,3–1,0%

Stevens-in 0,19–17,12 faizlik etibar intervalı nöqtə qiymətləndirməsi ilə birlikdə çap edilməlidir. Digər bütün rəqəmlərin etibar intervalı ilə verildiyi abzasda Yalnız 1,96 faizin göstərilməsi yalançı dəqiqlik təəssüratı yaradır, çünki ciddi seçmə altqoxluğu kiçikdir və qiymətləndirmə qeyri-sabitdir. — ciddi seçmə altçoxluğu kiçikdir və qiymət müvafiq olaraq qeyri-sabitdir.

Ən aşağı qiymətlər DSM-5 meyarlarını dörd iri beynəlxalq kohortda tətbiq edən Przybylski, Weinstein və Murayama-dan gəlir (seçmələr ikinci dərəcəli mənbələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Kanada və Almaniyadan götürülmüş kimi təsvir olunur). Oyun oynayan hər üç şəxsdən ikidən çoxu heç bir İOP simptomu bildirməmişdir və müəlliflər İOP ilə fiziki, sosial və psixi sağlamlıq nəticələri arasındakı əlaqələri nəticələri ziddiyyətli hesab etmişlər.

Cins bölgüsü

Kişilərin üstünlük təşkil etməsi ən ardıcıl epidemioloji tapıntıdır: kişilərdə 8,5%, qadınlarda 3,5% (Kim və b., 2022). İcmallar Su və həmkarlarının meta-analizinə istinad edərək bildirirlər ki, kişilər qadınlara nisbətən daha çox pozulmuş oyun davranışı, qadınlar isə daha çox problemli sosial media istifadəsi nümayiş etdirirlər (Musetti və b., 2025).

Yaş

Yayılma yeniyetmələr və gənc yaşlılarda ən yüksəkdir; Kim və b. (2022) tədqiqatında seçmənin orta yaşı bildirilən yayılma ilə mənfi əlaqədə olmuşdur — seçmə həcmi və tədqiqat keyfiyyəti ilə də mənfi əlaqə müşahidə olunmuşdur. Gentile və b. (2011) Sinqapur panel tədqiqatında — 3-cü, 4-cü, 7-ci və 8-ci siniflərdə 3 034 uşaq iki il müddətində izlənmişdir — hər hansı bir vaxt kəsiyində 7,6 ilə 9,9 faiz arasında şəxs patoloji oyunçu kimi təsnif edilərdi (xülasədə təxminən 9 faiz kimi ümumiləşdirilmişdir).

İki pediatrik sintez tez-tez birlikdə sitat gətirilir, halbuki gətirilməməlidir: Gentile və b. (2017) yaşdan, ölkədən və seçmə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq təxminən 1 ilə 9 faiz arasında diapazon bildirir, Paulus və b. (2018) isə uşaq və yeniyetmələrin reprezentativ seçmələrində təxminən 2 faiz, klinik seçmələr də daxil olmaqla bütün seçmələr birləşdirildikdə isə 5,5 faizlik orta yayılma bildirir.

Heterogenliyin mənbələri

Bildirilən yayılma tədqiqatlar arasında bir tərtib fərqlənir və əsas səbəb coğrafi deyil, metodoloji xarakterlidir. Stevens və b. (2021) tədqiqatında skrininq alətinin seçimi variasiyanın 77 faizini izah etmiş; yeniyetmə seçmələri, aşağı kəsmə həddi balları və kiçik seçmə həcmi isə daha yüksək yayılmanın əhəmiyyətli prediktorları olmuşdur. Kim və b. (2022) heterogenliyə təsir edən moderatorlar arasında regionu sadalayır; Stevens və b. tədqiqat regionunu namizəd moderator kimi araşdırmış, lakin onu əhəmiyyətli prediktorlar arasında bildirməmişdir. Buna görə də hər iki meta-analizin gücünə istinadən regional fərq iddia edilə bilməz və region alət, seçmə tipi və tədqiqat keyfiyyəti ilə qarışıq qalır.

Regional məlumat boşluğu

Bu axtarışda Azərbaycanda aparılmış, rəy verilmiş heç bir oyun oynama pozuntusu yayılma tədqiqatı aşkar edilməmiş və Cənubi Qafqaz üçün XBT-11 əsaslı heç bir yayılma göstəricisi tapılmamışdır. İstənilən yerli rəqəm ölçülmüş məlumat kimi deyil, yalnız ekstrapolyasiya kimi təqdim edilməlidir.

4. Etiologiya və patogenez

Vahid səbəb mexanizmi müəyyən edilməmişdir. Sübut bazasında en kəsiyi tədqiqatları üstünlük təşkil edir; mövcud ən güclü məlumatlar uzununa kohortlardan və risk amillərinin meta-analizlərindən gəlir.

Genetika

XBT-11 oyun oynama pozuntusu üçün birbaşa irsilik qiymətləri mövcud deyil. Ən yaxın sübut 5 247 monoziqot və diziqot yeniyetmə əkizini əhatə edən Netherlands Twin Register tədqiqatıdır; burada kompulsiv internet istifadəsindəki fərdi fərqlərin 48 faizi genetik amillərlə izah edilmiş, qiymətlər oğlanlarda və qızlarda eyni olmuş, qalan 52 faiz isə paylaşılmayan mühitə aid edilmişdir (Vink və b., 2016).

Bu rəqəm oyun oynama pozuntusuna köçürülməməlidir. İstifadə edilən alət — Kompulsiv İnternet İstifadəsi Şkalası (ing. Compulsive Internet Use Scale) — kompulsiv internet istifadəsini vahid ümumi konstrukt kimi ölçən 14 maddəlik vasitədir (kontrol itkisi, məşğuliyyət, kəsilmə, öhdəsindən gəlmə və ya əhval-ruhiyyənin dəyişdirilməsi, münaqişə) və oyuna xas heç bir bənd ehtiva etmir. Həmin tədqiqatda oyuna sərf edilən vaxt ayrı bir dəyişən kimi ölçülmüşdür və 48 faizlik qiymətin alındığı fenotip deyildi.

Nəzəri model

Ən geniş istifadə olunan inteqrativ çərçivə I-PACE modelidir (Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution); model asılılıq davranışlarının predispozisiya yaradan şəxsi dəyişənlər, daxili və xarici işarələrə affektiv və koqnitiv cavablar, habelə icraedici və inhibitor kontrol arasındakı qarşılıqlı təsirlərdən yarandığını, zamanla möhkəmləndirmənin isə davranışı həzz yönümlü olmaqdan kompensasiya yönümlü və vərdiş xarakterli olmağa keçirdiyini müdafiə edir (Brand və b., 2016; Brand və b., 2019). Model nəzəri baxımdan təsirlidir, lakin diaqnostik və ya proqnostik alət kimi etibarlılığı yoxlanılmamışdır və heç bir klinik qərar ona söykənməməlidir.

Neyrobiologiya

40 funksional təsvir tədqiqatını əhatə edən, «toxum əsaslı d xəritələmə» (seed-based d mapping) metodundan istifadə edən bütün beyin üzrə meta-analiz internet oyun

pozuntusunda beyində baş verən dəyişikliklərin tapşırıqdan asılı olduğunu aşkar etmişdir (Zheng və b., 2019):

Paradiqma	**Hiperaktivasiya**	**Hipoaktivasiya**
İşarə reaktivliyi	İkitərəfli prekuneus, ikitərəfli singulat qabıq	İnsula; **striatumda fərq yoxdur**
İcraedici nəzarət	Sağ yuxarı gicgah qırışığı, ikitərəfli prekuneus, ikitərəfli singulyar qabıq, insula	Sol aşağı alın payı qırışı (girus)
Riskli qərar qəbulu	Sol striatum, sağ aşağı alın qırışığı, insula	Sol yuxarı alın qırışığı, sol aşağı alın qırışığı, sağ presentral qırış

Burada iki dəqiqlik məqamı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, işarə reaktivliyi paradiqmalarında birləşdirilmiş mənfi nəticə bütövlükdə striatuma aiddir; bu tipli bütün beyin üzrə analiz xüsusi olaraq ventral striatum barədə iddiaya əsas vermir. İkincisi, müəlliflərin öz nəticəsi budur ki, tədqiqat İOP-də mükafat və icraedici kontrol dövrələrinin həlledici rolunu təsdiqləyir, lakin bütün şəraitlərdə deyil — bu, mükafat sisteminin iştirakının təkzibi deyil. həkimin buradan çıxarmalı olduğu nəticə daha dar və daha möhkəmdir: frontal tapıntılar birmənalı şəkildə «hipofrontal» deyil (riskli qərar qəbulu zamanı sağ aşağı alın payı qırışı hiperaktivləşmiş, sol isə hipoaktivləşmiş olmuşdur), tapıntılar en kəsiyi xarakterlidir və heç bir təsvir tapıntısı və heç bir bioloji marker diaqnostik dəyərə malik deyil.

Risk və qoruyucu amillər — en kəsiyi sintezi

Bu günə qədər ən geniş sintez COVID-19 pandemiyasından əvvəl dərc edilmiş 253 tədqiqatdan və 210 557 iştirakçıdan 1 586 effekti birləşdirmişdir. Empirik olaraq möhkəm qoruyucu amillər az saydadır — özünəqiymət, intellekt, həyatdan məmnunluq və təhsil — və hamısının effekt həcmi risk amillərinin təsir həcmindən nəzərəçarpacaq dərəcədə kiçik olmuşdur (Ropovik və b., 2023).

Risk və qoruyucu amillər — uzununa sintez

37 042 iştirakçı ilə 39 uzununa tədqiqatın meta-analizi klinik baxımdan ən istifadəyə yararlı strukturu verir (Zhuang və b., 2023).

Sahə	Risk amilləri	Qoruyucu amillər
Şəxsdaxili	Oyun vaxtı r = 0,33; təklik hissi r = 0,29; sosial media pozuntusu r = 0,24 (95% CI 0,03–0,43); aqressiya r = 0,23; təşviş r = 0,21	Özünə nəzarət r = −0,27; vicdanlılıq r = −0,25; uzlaşanlıq r = −0,20; özünəqiymət r = −0,19
Şəxslərarası	Deviant həmyaşıdlarla əlaqə r = 0,20; ailə tərəfindən zorakılıq r = 0,15	Həmyaşıdlarla münasibət r = −0,23; valideyn-övlad münasibəti r = −0,15; sosial dəstək r = −0,14
Ətraf mühit	—	Məktəbə bağlılıq r = −0,18

Şəxsdaxili amillər şəxslərarası və ya ətraf mühit amillərindən əhəmiyyətli dərəcədə daha güclü proqnozlaşdırıcı olmuşdur. Sosial media pozuntusuna aid geniş etibar intervalı həmin assosiasiyanın klinik praktikada istifadə edilməsindən əvvəl nəzərə alınmalıdır.

Səbəbiyyətin istiqaməti

Sinqapurun ikiillik panel tədqiqatı zaman ardıcıllığı haqqında danışa bilən az sayda məlumat dəstindən biridir. Daha çox oyun oynama, daha aşağı sosial sərişdə və daha yüksək impulsivlik patoloji oyunçuya çevrilmək üçün risk amilləri kimi çıxış edirdi; depressiya, təşviş, sosial fobiya və daha aşağı məktəb müvəffəqiyyəti isə patoloji oyunun səbəbləri deyil, nəticələri kimi çıxış edirdi (Gentile və b., 2011). Müəlliflərin öz ehtiyatlı ifadəsi — bu dəyişənlərin həmin rollarda «çıxış etdiyi görünürdü» — qorunmalıdır.

Diqqət çatışmazlığı/hiperaktivlik pozuntusu

Sistematik icmal və meta-analiz DDHP simptom ağırlığı ilə oyun oynama pozuntusu arasında orta assosiasiya aşkar etmişdir: birləşmiş DDHP simptomları üçün r = 0,296, diqqətsizlik üçün r = 0,306 və hiperaktivlik üçün r = 0,266 (Koncz və b., 2023). Bu, sahədəki ən ardıcıl komorbid assosiasiya və praktikada ən məhsuldar skrininq hədəfidir.

Oyun dizaynı və monetizasiya

7 422 oyunçu arasında aparılan sorğuda loot box-lara xərcləmə problemli qumar ağırlığı ilə assosiasiya olunmuşdur ($\eta^2 = 0,054$); bu assosiasiya real pulla edilən digər oyundaxili alışlar üçün olandan ($\eta^2 = 0,004$) bir dərəcə güclüdür və qumara bənzər

element üçün xas olduğuna işarə edir (Zendle və Cairns, 2018). Dizayn en kəsiyi xarakterlidir və müəlliflər açıq şəkildə bildirirlər ki, o, loot box-ların problemli qumara giriş qapısı kimi çıxış etməsini onların artıq problemli qumar oynayan insanlara daha çox cazibədar görünməsindən ayıra bilmir.

Rəqib psixoloji izah

Kompensator internet istifadəsi modeli həddindən artıq oyunu ilkin asılılıq kimi deyil, ödənilməmiş psixososial ehtiyacları ödəməyə və əlverişsiz həyat şəraitinə öhdəsindən gəlməyə cavab kimi konseptuallaşdırır (Kardefelt-Winther, 2014). Bu izah asılılıq modeli ilə birbaşa rəqabət aparır, həll olunmamış qalır və praktiki nəticəsi vardır: oyunu depressiv epizod və ya sosial böhranla eyni addımda artmış pasiyentdə oyunun təcrid olunmuş şəkildə müalicəsi çətin ki işə yarasın.

5. Klinik təzahürlər

Əsas təzahür

Klinik təzahürlər oynanılan saatlarla deyil, XBT-11-in üç məcburi komponenti ilə müəyyən edilir.

XBT-11 əlaməti	Klinik olaraq necə təzahür edir
Nəzarətin pozulması	Nəzərdə tutulan vaxtda dayandırmağın təkrar-təkrar mümkün olmaması; planlaşdırılandan uzun seanslar; azaltma cəhdlərinin uğursuzluğu; gecəyə uzanan «daha bir oyun»
Üstünlüyün artması	Oyun yuxunu, yeməyi, gigiyenanı, təhsili, işi, ailə öhdəliklərini və əvvəllər dəyərli olan məşğuliyyətləri sıxışdırıb çıxarır
Mənfi nəticələrə baxmayaraq davam etmə	Akademik uğursuzluq, iş itkisi, ailə münaqişəsi, maliyyə itkisi və ya sənədləşdirilmiş sağlamlıq zərərindən sonra da davam etmə

Müşayiət edən əlamətlər

Seanslar arasında oyunla məşğuliyyət, oyunun qarşısı alındıqda qıcıqlanma, yerində dura bilməmək və ya disforiya, oyun müddəti barədə aldatma və mənfi əhval-ruhiyyəni yüngülləşdirmək üçün oyundan istifadə DSM-5-TR meyar dəstində təsvir

olunur. XBT-11 tolerantlıq və ya kəsilmə tələb etməkdən qəsdən imtina edir və oyunda kəsilməyə bənzər fenomenlərin statusu mübahisəli qalır. Praktikada bu əlamətlər diaqnozu dəstəkləyir, lakin onu tək daşıya bilməz.

Funksional nəticələr

Klinik müraciətlərdə əsas şikayətləri adətən ailə bildirir: məktəb müvəffəqiyyətinin düşməsi, məktəbdən imtina və ya davamiyyətsizlik, gecə-gündüz rejiminin tərsinə çevrilməsi, oflayn həmyaşıdlardan uzaqlaşma və girişi məhdudlaşdırmaq cəhdləri ətrafında artan münaqişə. Pozuntunu intensiv asudə oyundan ayıran məhz funksional pozulma tələbidir (Billieux və b., 2019).

Yuxu

Gecə vaxtı oyun, yuxuya getmənin gecikməsi və yuxunun qısalması geniş şəkildə bildirilir. American Academy of Sleep Medicine konsensus tövsiyəsi 13–18 yaşlı yeniyetmələr üçün hər 24 saatda 8–10 saat yuxudur (Paruthi və b., 2016). Oyunu yuxunun pozulması ilə əlaqələndirən sübutlar müşahidə xarakterlidir, lakin yuxu vaxtı obyektiv sənədləşdirilə və müalicə boyu izlənilə bilən az sayda funksional göstəricidən biridir.

Fiziki sağlamlıq

Bildirilən fiziki korrelyatlara bel, boyun və çiyinlərdə dayaq-hərəkət ağrıları, əl və baş barmağın təkrarlanan gərginlik zədələnmələri, baş ağrısı və başgicəllənmə ilə müşayiət olunan göz yorğunluğu, habelə oturaq həyat tərzinin nəticələri daxildir. Bir təsviri icmal qeyd edir ki, hər on elektron idman oyunçusundan dördü ağrı bildirir və gündə beş saatdan çox oyun 13–18 yaşlı yeniyetmələr arasında dayaq-hərəkət simptomlarını artırmışdır (Satish Kumar və b., 2023). Eyni icmal bildirir ki, tədqiqatlar çox azdır, sübutlar ziddiyyətlidir, qiymətləndirmə alətləri etibarlılığı yoxlanılmamışdır və yeniyetmələrdə heç bir uzununa iş aparılmamışdır. Bu, zəif sübut sahəsidir və belə də təqdim edilməlidir.

Komorbidlik

DDHP ən ardıcıl assosiasiyanı göstərir ($r \approx 0{,}30$; Koncz və b., 2023). Depressiya və təşviş tez-tez bildirilir, lakin bu təəssüratın altında duran sintez ədəbiyyatı qiymətləndirməyə tab gətirmir: oyun oynama pozuntusunun depressiya və ya təşvişlə əlaqəsinə dair yeddi sistematik icmalın hamısında — ümumilikdə 196 ilkin tədqiqatı əhatə edən — hamısında seçmə nəticə bildirilməsi sübutu tapılmış, yalnız biri yanlılıq riskini qiymətləndirmiş və məruz qalma tərifləri ardıcıl olmamışdır: daxil edilən bəzi tədqiqatlar oyun oynama pozuntusu deyil, internet asılılığı ölçülərindən istifadə etmişdir. Heç biri etibarlı kimi təsnif edilməmiş və müəlliflər belə nəticəyə

gəlmişlər ki, oyun oynama pozuntusuna dair sistematik icmallar metodoloji standartlara cavab vermir (Colder Carras və b., 2020). Buna görə də komorbidlik tez-tez müşahidə olunan, lakin zəif kəmiyyətləndirilmiş kimi təsvir edilməli, komorbid affektiv və ya təşviş pozuntusu isə oyun oynama pozuntusunun bir hissəsi kimi qəbul edilməkdənsə, ayrıca pozuntu kimi qiymətləndirilməli və müalicə edilməlidir.

Onlayn və oflayn alt tip

Əsasən onlayn forma (6C51.0) daha tez-tez təsvir olunan təzahürdür və çoxoyunçulu, davamlı virtual dünyaları olan və rəqabətli oyunlarla assosiasiya olunur. Əsasən oflayn forma (6C51.1) tanınır, lakin xeyli az öyrənilmişdir.

Klinik təzahürlərə daxil olmayanlar

Funksiyası, yuxusu, münasibətləri və öhdəlikləri qorunan şəxsdə uzun oyun saatları oyun oynama pozuntusu təşkil etmir. Yeni bir icmalda bildirilən şəxsyönümlü tədqiqat gündə dörd saatdan çox oynayan və aşağı səviyyədə psixoloji uyğunsuzluq göstərən «həvəsli oyunçu» altqrupunu müəyyən etmişdir (Musetti və b., 2025). Yüksək cəlb olunma ilə patoloji cəlbolunma arasındakı fərq diaqnozun etibarlılığı üçün əsasdır (Billieux və b., 2019).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

Aşağıdakıların hamısı mövcud olmalıdır:

- oyun üzərində kontrolun pozulması — başlanğıc, tezlik, intensivlik, müddət, dayandırılma və kontekst;
- oyuna verilən üstünlüyün artması — belə ki, oyun digər həyati maraqlar və gündəlik fəaliyyətlər üzərində üstünlük təşkil edir;
- mənfi nəticələr yaranmasına baxmayaraq oyunun davam etdirilməsi və ya artırılması;
- və patern şəxsi, ailəvi, sosial, təhsil, peşə və ya digər mühüm funksional sahələrdə əhəmiyyətli pozulma ilə nəticələnir.

Müddət: oyun davranışı nümunəsi və digər simptomlar adətən ən azı 12 ay ərzində müşahidə olunur, lakin bütün diaqnostik tələblər ödənildikdə və simptomlar ağır olduqda tələb olunan müddət qısaldıla bilər. Alt tipi dəqiqləşdirin: 6C51.0 əsasən onlayn, 6C51.1 əsasən oflayn, 6C51.Z dəqiqləşdirilməmiş.

6.2 Diaqnozun praktikada etibarlılığı

XBT-11 təlimatlarını birbaşa yoxlayan bir sahə tədqiqatı var. Şanxay və Xebeydə 15 –18 yaşlı 200 oyunçu (orta yaş 16,5, 85,6 faizi kişi) yeddi psixiatrdan formalaşdırılmış 21 qiymətləndirici cütü tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndiricilərarası uzlaşma XBT-11 oyun oynama pozuntusu təlimatları üçün κ = 0,545 (95% etibar intervalı 0,490–0,600) — müəlliflərin özlərinin istinad etdiyi Landis və Koch təsnifatına görə orta — DSM-5 İOP üçün isə κ = 0,622 (95% CI 0,553–0,691) olmuşdur. Eyni pasiyentlərə tətbiq edilən iki sistem arasında uzlaşma κ = 0,847 (95% CI 0,814–0,880) təşkil etmişdir. həkimlər 400 qiymətləndirmə dəstinin 86,0 faizində təlimatların klinik tətbiq oluna bilməsini kifayət qədər və ya son dərəcə yaxşı qiymətləndirmişlər (Ma və b., 2021).

Bu iki kappa əmsalının sadəcə yanaşı qoyulması birbaşa müqayisə sayılmır və XBT-11-in daha az etibarlı sistem olduğuna dair qəti sübut kimi bildirilməməlidir. XBT-11 qiyməti üç kateqoriyalı mühakimədən (oyun oynama pozuntusu / təhlükəli oyun oynama / heç biri), DSM-5 qiyməti isə iki kateqoriyalı mühakimədən (İOP var / yox) gəlir. Üç kateqoriyalı kappa DSM-5-də qarşılığı olmayan aralıq təhlükəli oyun oynama kateqoriyası ətrafındakı fikir ayrılıqları hesabına struktur olaraq cəzalandırılır. Rəqəmlərlə birlikdə daha üç məhdudiyyət verilməlidir: bütün 200 oyunçu vahid peşə və texniki təhsil mərkəzindən skrininq yolu ilə seçilmişdir; cəmi yeddi qiymətləndirici olmuşdur; və WHO sahə tədqiqatlarında istifadə edilən eyni vaxtda birgə qiymətləndirmə dizaynı müstəqil təkrar müsahibəyə nisbətən daha yüksək kappa qiymətləri yaratmağa meyllidir, ona görə də 0,545 gündəlik praktika üzrə aşağı həddeyil, daha çox yuxarı həddkimi qiymətləndirilməlidir. Təkrarlama yoxdur.

Eyni tədqiqat həm də geniş yayılmış bir fərziyyəni aradan qaldırır. Eyni 400 qiymətləndirmə dəstinə tətbiq edildikdə XBT-11 meyarları 400 qiymətləndirmə dəstinin 86-sında, DSM-5 meyarları isə 78-ində pozuntu aşkar etmişdir və sistemlər arasında uzlaşma demək olar ki, mükəmməl olmuşdur. Buna görə də tədqiqatlar arasında bildirilən yayılma fərqləri sadəcə alətin hansı təlimata əsaslanması ilə izah edilə bilməz; alətin özü, onun kəsim həddi və seçmə qat-qat daha çox əhəmiyyət daşıyır (3-cü bölməyə bax).

6.3 12 aylıq tələb nə üçün ixtiyari deyil

Oyun oynama pozuntusu diaqnozunun statusu zaman keçdikcə nəzərəçarpacaq dərəcədə qeyri-sabitdir. 50 uzununa tədqiqatın meta-analizi bir ildə təxminən 43–45 faiz, iki ildə isə 34–38 faiz kateqoriyalar üzrə stabillik aşkar etmiş (Sun və b., 2025), bir illik uzununa tədqiqat isə diaqnostik həddin hər iki istiqamətdə əhəmiyyətli dərəcədə keçildiyini müəyyən etmişdir (Hong və b., 2023). Tək qiymətləndirmədə

həddi keçən şəxslərin böyük hissəsi heç bir müalicə olmadan bir il sonra həmin həddin üstündə olmayacaq. 12 aylıq tələb keçici epizodun — imtahan dövrü, itirilmiş iş, yas, limitsiz internet bağlantısı ilə keçən yay tətili — psixiatrik diaqnoza çevrilməsinin qarşısını alan amildir. İcazə verilən qısaltma yalnız hər bir diaqnostik tələb artıq ödənildikdə və simptomlar ağır olduqda tətbiq edilir; bu, təəssürat əsasında erkən diaqnoz qoymağa əsas deyil.

6.4 Normallıqla sərhəd

Bacarığın inkişafı, rəqabət və ya istirahət məqsədilə aparılan intensiv oyun, kontrolun pozulması və funksional pozulma olmadıqda pozuntu deyil. Meyarlarda vaxt həddi yoxdur; oynanılan saatlar diaqnostik deyil. ÜST-ün açıq təlimatında bildirilir ki, oyun oynama pozuntusu rəqəmsal oyun və ya videooyunla məşğul olan insanların yalnız kiçik bir hissəsinə təsir edir. Bu, yalançı-müsbət diaqnoza qarşı əsas qorunma vasitəsidir (Billieux və b., 2019).

6.5 Diaqnostik alqoritm

- Addım 1. Oyun paterninin mövcudluğunu müəyyən edin və onu xarakterizə edin: oyunlar, platforma, onlayn və ya oflayn, seansın strukturu, qənimət qutusu (ing. loot box) daxil olmaqla monetizasiyaya məruz qalma.
- Addım 2. Üç əsas komponentin hər birini özünü etiketləmə ilə deyil, konkret davranış nümunələri ilə ayrı-ayrılıqda qiymətləndirin.
- Addım 3. Funksional pozulmanı obyektiv sənədləşdirin — məktəb və ya iş qeydləri, yuxu, ailənin məlumatı, əvvəlki fəaliyyətlərin itirilməsi. Pozulma olmadıqda əvəzinə QE22 Təhlükəli oyun oynamanı nəzərdən keçirin.
- Addım 4. 12 aylıq zaman çərçivəsini müəyyən edin və ya onu qısaltmağa kifayət edən ağırlığı sənədləşdirin.
- Addım 5. Davranışın yeganə konteksti kimi manik və ya hipomanik epizodu (6A60, 6A61) istisna edin.
- Addım 6. Komorbidlik üçün sistematik skrininq aparın: əvvəlcə DDHP, sonra depressiv pozuntular, təşviş pozuntuları və sosial narahatlıq pozuntusu, maddə istifadəsi və yuxu pozuntuları.
- Addım 7. Etibarlılığı təsdiqlənmiş alətdən (GDT — Oyun Pozuntusu Testi, ACSID-11, IGDT-10, IGDS9-SF) yalnız köməkçi vasitə kimi istifadə edin. Heç bir alət təkbaşına diaqnostik deyil.

6.6 XBT-11 və DSM-5-TR-in müqayisəsi

—	**XBT-11 6C51 Oyun oynama pozuntusu**	**DSM-5-TR İnternet oyun pozuntusu**
Status	Formal diaqnoz	III Bölmə, Conditions for Further Study
Struktur	Üç məcburi komponent, hamısı tələb olunur	Doqquz təklif edilmiş meyar, beş və ya daha çoxu tələb olunur
Pozulma	Məcburi, ayrıca tələb	Diaqnostik başlıqda ehtiva olunmuşdur (klinik olaraq əhəmiyyətli pozulma və ya əzab-əziyyət), əlavə meyar deyil
Tolerantlıq və kəsilmə	Daxil edilməyib	Doqquz meyar arasında daxil edilib
Zaman çərçivəsi	Adətən ən azı 12 ay; ağır olduqda qısaldıla bilər	12 aylıq dövr ərzində
Əhatə	Onlayn və ya oflayn; alt tiplər kodlaşdırılıb	Onlayn oyunlar ətrafında qurulub
Həddən aşağı kod	QE22 Təhlükəli oyun oynama	Yoxdur

XBT-11-in pozulmaya verdiyi daha böyük əhəmiyyət ümumiyyətlə ona daha yüksək diaqnostik hədd verən amil kimi oxunur (Musetti və b., 2025).

6.7 Bir il ərzində diaqnostik stabillik

279 iştirakçının — problemli oyun oynayan 120 pasiyent və ümumi əhalidən 159 oyunçu — bir illik uzununa tədqiqatında iştirakçıların 34,7 faizində DSM-5 İOP diaqnozu dəyişmiş, XBT-11 üzrə oyun oynama pozuntusu diaqnozu alanların payı isə 60,4 faizə yüksəlmişdir (Hong və b., 2023). Bu iki rəqəm fərqli kəmiyyətlərdir və eyni olduğu kimi bir-birinə qarşı qoyulmamalıdır: 34,7 faiz diaqnostik dəyişiklik dərəcəsi, 60,4 faiz isə oyun oynama pozuntusu hallarının yüksəldiyi səviyyədir. Müəlliflər açıq şəkildə bildirirlər ki, il ərzində İOP və GD diaqnostik dəyişikliklərinin miqdarı arasında əhəmiyyətli fərq yox idi, onların şərhi isə ehtiyatlıdır — oyun oynama pozuntusu diaqnozu İOP diaqnozuna nisbətən dəyişməyə daha *meylli ola bilər*. Hər ikisi üçün ən yüksək şanslar nisbətini DDHP daşıyırdı; oyun oynama pozuntusu üçün bildirilən nöqtəvi qiymət 10^6

səviyyəsindədir, buna uyğun olaraq həddindən artıq geniş etibar intervalına malikdir və effekt həcmi kimi şərh edilə bilməz; bu, demək olar ki, mütləq modeldəki kvazi-tam separasiyanı (quasi-complete separation) əks etdirir.

Klinik nəticə birbaşadır: tək en kəsiyi qiymətləndirməsi yalnız həmin ana aid diaqnoz qoyur, proqnoz vermir; təkrar qiymətləndirmə isə seçim deyil, müalicə prosesinin bir hissəsidir.

6.8 Differensial diaqnoz

Kod	Vəziyyət	Fərqləndirici məqam
QE22	Təhlükəli oyun oynama	Zərər riskini nəzərəçarpacaq dərəcədə artıran, lakin 6C51-in tələblərinə cavab verməyən oyun — bu, adətən nəzarətin pozulması və ya əhəmiyyətli pozulma olmadığı üçün belədir. Oyun davranışı nümunəsi məsləhət tələb etdikdə, lakin pozuntu diaqnozunu tələb etmədikdə bu kod istifadə edilir.
6C50	Qumar oynama pozuntusu	Qumar oynama pozuntusunun əsas xüsusiyyəti nəticəsi qeyri-müəyyən olan hadisələrə pul və ya qiymətli əşya qoymaqdan ibarətdir. Sərhəd qumara bənzər oyundaxili ödəniş modelləri ilə sərhədi aydın seçilmir; hər iki davranışı qiymətləndirin və meyarlara cavab verdikdə hər ikisini kodlaşdırın.

Kod	Vəziyyət	Fərqləndirici məqam
6A60 / 6A61	Bipolyar I/II tip pozuntu	Formal XBT-11 istisnaları. Yalnız manik və ya hipomanik epizod çərçivəsində baş verən həddindən artıq oyun oynama affektiv epizodun simptomudur.
6A05	Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu	Ən güclü və ən ardıcıl komorbidlik. Nizamsız, zəif tənzimlənən oyunla gedən ilkin Diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusunu (DDHP) müstəqil oyun oynama pozuntusundan fərqləndirin; ikisi tez-tez birgə mövcud olur və meyarlar ödənildikdə hər ikisi kodlaşdırılmalıdır.
6A70 / 6A71 / 6A72	Depressiv pozuntular	Əsasən depressiv əhval-ruhiyyədən qaçmaq və ya onu yüngülləşdirmək üçün istifadə edilən oyun ikinci dərəcəli əlamət ola bilər. Zaman ardıcıllığını və affektiv pozuntu müalicə olunduqdan sonra oyunla bağlı pozulmanın davam edib-etmədiyini qiymətləndirin.

Kod	**Vəziyyət**	**Fərqləndirici məqam**
6B00/6B04	Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu / Sosial təşviş pozuntusu	Sosial təşvişdə qaçınma mənfi qiymətləndirilmə qorxusu ilə idarə olunur; oyun oynama pozuntusunda isə hərəkətverici qüvvə oyun üzərində kontrolun pozulması və oyunun digər həyat maraqları üzərində üstünlük təşkil etməsidir.
6A02	Autizm spektri pozuntusu	Güclü və daralmış maraq asılılıq prosesini deyil, məhdud maraq dairəsini əks etdirə bilər. Uzunmüddətli, artmayan və pozulma yaratmayan xüsusi maraq 6C51 (oyun oynama pozuntusu) diaqnozuna uyğun gəlmir.
6C40–6C4G	Maddə istifadəsi ilə əlaqədar pozuntular	Oyun davranışının maddə istifadəsindən və ya intoksikasiyadan asılı olmayaraq davam edib-etmədiyini qiymətləndirin.
6A20	Şizofreniya	Uzunmüddətli təkbaşına daxil olma (immersiya) neqativ simptomlar, sosial uzaqlaşma və ya oyun məzmunu ilə bağlı sayıqlama məşğuliyyəti kontekstində baş verə bilər.

Kod	Vəziyyət	Fərqləndirici məqam
6B20	Obsessiv-kompulsiv pozuntu	Müdaxiləedici fikirlər və təşvişin azaldılması ilə idarə olunan ritualizə olunmuş oyundaxili davranış oyun oynama pozuntusunun həzz ardınca vərdiş formalaşan modeldən fərqli olaraq əvvəldən eqo-distondur.
6C5Y / 6C5Z	Asılılıq davranışları ilə əlaqədar digər dəqiqləşdirilmiş / dəqiqləşdirilməmiş pozuntular	Nə oyun, nə də qumar tərifinə uyğun gəlməyən, digər onlayn fəaliyyətlər — sosial şəbəkələr, alış-veriş, pornoqrafiya istifadəsi — ətrafında mərkəzləşən asılılıq davranışı modelləri bu kateqoriyaya aiddir.
7A00–7A0Z	İnsomniya pozuntuları	Yuxu pozulmasının oyun paterninin nəticəsi, yoxsa müstəqil yuxu-oyanıqlıq pozuntusu olduğunu müəyyən edin.

Bir differensial sual cavabsız qalır: affektiv və ya diqqət pozuntusu ilə yaranıb onunla remissiyaya gedən oyunun ümumiyyətlə ilkin vəziyyət olub-olmaması. Bu, tanınmış tədqiqat prioriteti olaraq qalır (Musetti və b., 2025) və hər bir konkret pasiyentdə praqmatik şəkildə həll olunur — komorbid pozuntunu düzgün müalicə etmək və oyunla bağlı pozulmanın onunla birlikdə aradan qalxıb-qalxmadığını müşahidə etməklə.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

Ümumi prinsip

Oyun oynama pozuntusuna diaqnoz qoya bilən heç bir bioloji test və heç bir neyrovizuallaşdırma tapıntısı yoxdur, diaqnostik biomarker müəyyən edilməmişdir. Diaqnoz klinik müsahibəyə əsaslanır; psixometrik alətlər yalnız skrininq və ağırlığın qiymətləndirilməsi vasitələridir və heç biri təkbaşına diaqnoz qoymaq və ya istisna etmək üçün istifadə edilməməlidir.

Alətlər

Alət	**Çərçivə**	**Struktur və hesablama**	**Etibarlılıq və kəsim həddi**
Gaming Disorder Test (GDT) Pontes və b., 2021	XBT-11	4 maddə, 5 ballı Likert, cəmi 4–20; yüksək bal = daha ağır	Onlayn cəlb edilmiş 236 çinli və 324 britaniyalı oyunçuda hazırlanmışdır. Daxili ardıcıllıq 14 dildə 17 tədqiqatı əhatə edən 2024-cü il etibarlılığın ümumiləşdirilməsi meta-analizi ilə dəstəklənir (birləşdirilmiş α = 0,86, 95% ET 0,83 –0,89). Vahid, universal etibarlılığı yoxlanılmış diaqnostik kəsim həddi yoxdur.

Alət	Çərçivə	Struktur və hesablama	Etibarlılıq və kəsim həddi
ACSID-11 Müller və b., 2022	XBT-11	Oyuna, alış-verişə, pornoqrafiya istifadəsinə, sosial şəbəkə istifadəsinə və onlayn qumara eyni şəkildə tətbiq edilən 11 maddə	985 aktiv internet istifadəçisindən ibarət alman seçməsində hazırlanmışdır. Tailandda (2023) və Çində yeniyetmələr arasında aparılan etibarlılıq yoxlanışları oyunu əhatə edir; bu günədək dərc edilmiş ingilisdilli etibarlılıq yoxlanışı isə oyunu deyil, Tinder və onlayn pornoqrafiya istifadəsini əhatə edir. Ölçü xarakteri daşıyır; diaqnostik kəsim həddi yoxdur.

Alət	Çərçivə	Struktur və hesablama	Etibarlılıq və kəsim həddi
IGDT-10 Király və b., 2017	DSM-5	Doqquz meyarı operasionallaşdıran 10 maddə; bal diapazonu 0–9	4 887 onlayn oyunçuda (14–64 yaş, orta yaş 22,2, 92,5% kişi) hazırlanmışdır. ≥ 5 kəsim həddi ehtimal olunan İOP-ni göstərir. Yeddi dil əsaslı seçmə (7 193 iştirakçı) üzrə şkala üzrə ölçmə dəyişməzliyi ayrıca 2019-cu il tədqiqatında göstərilmişdir.
IGDS9-SF Pontes and Griffiths, 2015	DSM-5	9 maddə, 5 ballı şkala; meyar əsaslı qiymətləndirmə (doqquzdan ən azı beşinin ən yüksək tezlikdə təsdiqlənməsi)	1 397 ingilisdilli oyunçuda (85,1% kişi, orta yaş 27) hazırlanmışdır. 15 dil versiyası üzrə 21 tədqiqatın sistematik icmalı birölçülü strukturu təsdiqləmişdir (Poon və b., 2021). Qəti etibarlılığı yoxlanılmış vahid ümumi bal həddi yoxdur.
AICA-S	Klinik (internet və kompüter oyunu asılılığı)	Ağırlıq şkalası	Almaniya-Avstriya çoxmərkəzli randomizə edilmiş sınağında (STICA) əsas nəticə ölçüsü (müalicənin sonunda d = 1,19).

Alətlərə dair kritik xəbərdarlıq

Üç peşəkar qiymətləndirici tərəfindən müstəqil qiymətləndirilən 417 maddədən ibarət maddə bankını əhatə edən oyun oynama pozuntusu üzrə 29 skrininq alətinin zahiri etibarlılığının qiymətləndirilməsi əhatə, ifadə tərzi və həddindən artıq patologiyalaşdırma ilə bağlı sistematik problemləri, o cümlədən normal intensiv cəlb olunmanı əks etdirən maddələri, aşkar etmişdir (King və b., 2020). Bu, nəzəri bir mülahizə deyil: ən böyük yayılma dərəcəsi (prevalans) meta-analizində skrininq alətinin seçimi tədqiqatlararası variasiyanın 77 faizini izah etmişdir (Stevens və b., 2021). Kəsim həddindən yuxarı alət balı diqqətlə müsahibə aparmaq üçün səbəbdir, heç vaxt diaqnozun özü deyil.

Tövsiyə olunan qiymətləndirmə paketi

- XBT-11-in üç komponenti və sənədləşdirilmiş funksional pozulma üzrə strukturlaşdırılmış klinik müsahibə.
- Ailədən və ya məktəbdən alınan əlavə tarixçə — yetkinlik yaşına çatmayanlarda vacibdir.
- Zaman içində ağırlığın izlənməsi üçün XBT-11 ilə uzlaşan bir alət (GDT və ya ACSID-11).
- Sistematik komorbidlik skrininqi: əvvəlcə DDHP ($r \approx 0{,}30$), sonra depressiv və təşviş pozuntuları, maddə istifadəsi və sosial təşviş.
- Yuxunun qiymətləndirilməsi; istinad nöqtəsi kimi Amerika Yuxu Tibb Akademiyasının (AASM) yeniyetmələr üçün 8–10 saat tövsiyəsi.
- Qumara bənzər monetizasiyaya məruz qalmanın (oyundaxili qumar qutuları (ing. loot box), oyundaxili alışlar) və müşayiət edən istənilən qumar davranışının qiymətləndirilməsi.
- İzləmə üçün ilkin funksional göstəricilər: məktəbə və ya işə davamiyyət və müvəffəqiyyət, yuxu vaxtı, oflayn sosial təmaslar, fiziki aktivlik.

8. Müalicə

Dünyada oyun oynama pozuntusu üçün təsdiqlənmiş heç bir farmakoterapiya yoxdur. Heç bir dərman bu göstəriş üzrə FDA təsdiqinə malik deyil və öyrənilmiş hər bir preparat göstərişdən kənar (off-label) istifadə edilmişdir. Oyun oynama pozuntusuna həsr olunmuş heç bir Cochrane sistematik icmalı aşkar edilməmişdir; NICE qumarla bağlı zərərlərə dair təlimat dərc etmişdir (NG248, 28 yanvar 2025), lakin oyun oynama pozuntusunu əhatə edən təlimat yoxdur; oyun oynama pozuntusuna spesifik heç bir WFSBP (Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyası), CANMAT (Kanada Əhval Pozuntuları Şəbəkəsi), NIMH, SAMHSA və ya VA-DoD klinik göstərişi aşkar edilməmişdir. Rəsmi təsnifata daxil edilmiş pozuntu üçün bu,

diqqətçəkən boşluqdur və deməli, həkim təlimatlardan deyil, ilkin sınaqlardan çıxış edir.

8.1 Farmakoterapiya: mövcud sübutların həcmi

Bütün farmakoloji ədəbiyyat 724 iştirakçı barədə məlumat verən 12 klinik sınağın sistematik icmalında ümumiləşdirilmişdir. Onun məhdudiyyətləri bu icmaldan nəyin çıxarıla bildiyini və nəyin çıxarıla bilməyəcəyini müəyyən edir:

- iştirakçıların 98,6 faizi kişi olmuşdur (cinsi bildirilən 694 nəfərdən 684-ü);
- bütün sınaqlar Cənubi Koreyada aparılmışdır;
- 12 sınaqdan 8-i açıq etiketli (open-label) olmuş və ümumilikdə yalnız dörd tədqiqat aşağı yanlılıq riski ilə qiymətləndirilmişdir.

Bütün sınaqlar üzrə İOP simptomlarının müalicədən əvvəlki səviyyədən müalicədən sonrakı səviyyəyə azalması 15,4 ilə 51,4 faiz arasında olmuşdur — bu diapazon tamamilə bupropion tədqiqatları hesabına formalaşmışdır (Sá və b., 2023).

Preparat	**İştirakçıların payı**	**Bildirilən simptom azalması**
Bupropion (o cümlədən uzadılmış təsirli forma), 6 sınaq	26,9% (n = 195)	15,4–51,4%
SSGİ — fluoksetin, essitalopram, paroksetin, 6 məqalə	23,3% (n = 169)	17,6–24,0%
Metilfenidat, 2 məqalə	14,6% (n = 106)	23,7–25,7%
Atomoksetin, 1 məqalə	5,5% (n = 40)	18,3%

Bu rəqəmlərin oxunmasında komorbidlik mərkəzi əhəmiyyət daşıyır. 12 sınaqdan yeddisi ilk növbədə İOP-yə yönəlmiş və 461 iştirakçını (ümumi sayın 63,6 faizi) əhatə etmişdir; həmin yeddi sınaqdan beşi eyni zamanda psixiatrik komorbidliyi — ən çox DDHP və böyük depressiv pozuntu — olan 298 iştirakçını, yəni bütün birləşdirilmiş seçmənin təxminən 41 faizini cəlb etmişdir. Başqa sözlə, müşahidə olunan yaxşılaşmanın əhəmiyyətli hissəsi oyun davranışına deyil, komorbid pozuntuya aid ola bilər.

Ən məlumatverici iki fərdi sınaq:

- Han and Renshaw (2012). Major depressiv pozuntusu və həddindən artıq onlayn oyun oynaması olan 50 kişidə on iki həftəlik prospektiv, randomizə edilmiş, ikiqat kor sınaq (səkkiz həftə aktiv müalicə, dörd həftə izləmə).

Bupropion və internet istifadəsi üzrə maarifləndirmə Young internet asılılığı şkalasının (ing. Young Internet Addiction Scale) ballarını və orta oyun vaxtını plasebo və maarifləndirmədən daha çox azaltmışdır. Klinik baxımdan əhəmiyyətli təfərrüat: dörd həftəlik izləmə ərzində onlayn oyunun azalması davam etdiyi halda depressiv simptomlar təkrarlanmışdır.

- Nam və b. (2017). Major depressiv pozuntusu və həddindən artıq onlayn oyun oynaması olan pasiyentlərdə bupropionun essitalopramla on iki həftəlik ikiqat kor müqayisəsi. Hər iki qrup depressiv və İOP simptomları üzrə yaxşılaşmış, lakin yalnız 30 pasiyentdən (hər qolda 15 nəfər) ibarət seçmə ilə bu sınaq heç bir müqayisəli effektivlik iddiasını dəstəkləyə bilməz.

Klinik qayda. Oyun oynama pozuntusunda farmakoterapiya hazırda oyun davranışının özünə deyil, komorbidliyə — DDHP, depressiyaya — yönəlmişdir. O, komorbid pozuntunun göstərişi ilə təyin edilməli, oyun nəticəsi isə vəd edilməkdənsə izlənməlidir.

8.2 Psixoterapiya: koqnitiv-davranış terapiyası ən yaxşı əsaslandırılmış seçimdir

Mövqeyi üç sintez və bir çoxmərkəzli sınaq müəyyən edir.

- Stevens və b. (2019). 12 müstəqil KDT tədqiqatının meta-analizi. Test sonrası İOP simptomlarına müalicəyəqədər–müalicədənsonra effekt g = 0,92 (95% CI 0,50–1,34); depressiya g = 0,80 (0,21–1,38); təşviş g = 0,55 (0,17–0,93). Bunlar nəzarətli qruplararası müqayisələr deyil, müalicədən əvvəl–müalicədən sonra effektləridir və bu fərq əhəmiyyət daşıyır, çünki söhbət sahənin əsas kəmiyyətindən gedir. Təcrübəni müəyyən edən əsas tapıntı isə aşağıdakıdır: izləmə mərhələsində müalicə qazancları dörd nəticənin hamısı üzrə — yalnız depressiya və təşviş deyil, İOP simptomları da daxil olmaqla — əhəmiyyətsiz olmuşdur. KDT-dən əldə edilən qazanclar qısamüddətli perspektivdə nümayiş etdirilmişdir, davamlılığı isə nümayiş etdirilməmişdir.
- Wölfling və b. (2019) — STICA sınağı. Randomizə edilmiş sınaqdan əldə edilmiş ən yüksək keyfiyyətli sübut: Almaniya və Avstriyada dörd ambulator klinikada aparılan çoxmərkəzli RKİ; 143 kişi manuallaşdırılmış qısamüddətli KDT-yə (n = 72) və ya gözləmə siyahısı nəzarətinə (n = 71) randomizə edilmişdir. Remissiya müalicə qrupunun 69,4 faizində, nəzarət qrupunun isə 23,9 faizində baş vermişdir (şans nisbəti (odds ratio) 10,10, 95% ET 3,69–27,65; ilkin ağırlıq, komorbidlik, mərkəz və yaşa görə düzəliş edilmişdir). Müalicənin sonunda effekt həcmləri: d = 1,19 (AICA-S), d = 0,88 (iş günlərində onlayn keçirilən vaxt), d = 0,64 (psixososial funksiya), d = 0,67 (depressiya). Doza həftədə bir dəfə 15 qrup seansı, üstəgəl iki həftədə bir dəfə olmaqla səkkizə qədər fərdi seans — təxminən dörd ay ərzində təxminən 23 seansa qədər — olmuşdur; bu nəticəni təkrarlamağı

planlaşdıran xidmət məhz bu resursları təmin etməlidir. Məhdudiyyətlər: yalnız kişilərdən ibarət seçmə və daxiletmənin ciddi şəkildə XBT-11 oyun oynama pozuntusu meyarlarına deyil, əsas diaqnoz kimi internet asılılığına əsaslanması.

- Ock və b. (2025). Qeyri-farmakoloji müdaxilələrə dair 18 randomizə edilmiş klinik sınağın (RKİ) meta-analizi (1 950 iştirakçı): birləşdirilmiş g = −0,82 (95% CI −1,23 ilə −0,52; I^2 = 90,36%). Əsasən KDT olmaqla psixoterapiya ən böyük effekti göstərmişdir (10 tədqiqat, 1 036 iştirakçı; g = −1,34); davranış müdaxilələri g = −0,38; profilaktikaya yönəlmiş iş g = −0,33, müalicə isə g = −1,13; yaşlılar yeniyetmələrdən daha çox yaxşılaşmışdır (g = −1,14, yeniyetmələrdə −0,45). Nəşr yanlılığı statistik olaraq təsdiqlənmişdir (Begg p = 0,043; Egger p = 0,002). Digər xəbərdarlıq əlaməti: aşağı yanlılıq riski ilə qiymətləndirilən dörd tədqiqat digərlərindən daha böyük effekt vermişdir (g = −4,08); bu, böyük həqiqi effektə deyil, qeyri-sabit sübut bazasına işarə edən qeyri-real qiymətdir.
- Danielsen və b. (2024). Ən konservativ sintez — 38 tədqiqat, 76 effekt həcmi, 9 524 iştirakçı — orta səviyyəli yekun nəticə çıxarmışdır; müəlliflər bildirirlər ki, tapıntılara olan etimad kiçik tədqiqat effektləri, mümkün nəşr yanlılığı, məhdud tədqiqat bazası və standartlaşdırmanın olmaması ilə zəiflədilir.

8.3 Qısamüddətli abstinensiya

24 yetkin oyunçuda — onlardan 9-u İOP üzrə müsbət skrininq nəticəsi vermişdir — könüllü 84 saatlıq abstinensiya protokolu oyun saatlarını, dezadaptiv oyun koqnisiyalarını və İOP simptomlarını azaltmış, tam uyğunluq təmin edilmişdir və heç bir iştirakçı tədqiqatdan çıxmamışdır; 28-ci gündə İOP qrupunun 75 faizi İOP simptomlarında klinik olaraq əhəmiyyətli yaxşılaşma, 63 faizi isə dezadaptiv koqnisiyalarda etibarlı yaxşılaşma göstərmişdir (King və b., 2017). Bu, kiçik pilot tədqiqatdır. Abstinensiya və nəzarətli istifadə məqsədləri heç vaxt adekvat güclü sınaqda müqayisə edilməmişdir və müalicə məqsədi qabaqcadan müəyyən edilməkdənsə, fərdi qaydada seçilməlidir.

8.4 Ailə və inkişaf müdaxilələri

Yeniyetmələr üçün psixososial müdaxilə proqramı (PIPATIC) — 12–18 yaşlı yeniyetmələr üçün manuallaşdırılmış altı modullu fərdiləşdirilmiş psixoterapiya; psixoedukasiya və motivasiya, İOP-yə uyğunlaşdırılmış standart asılılıq müalicəsi, şəxsdaxili, şəxslərarası, ailə və yeni həyat tərzi modullarından ibarətdir və altı ay ərzində hər biri təxminən 45 dəqiqə olan 22 seans şəklində təqdim olunur — iki ictimai psixi sağlamlıq mərkəzində standart KDT ilə müqayisə edilmişdir. Hər iki

qrup İOP simptomlarının əhəmiyyətli azalmasını göstərmişdir (Torres-Rodríguez və b., 2018). Həlledici məhdudiyyət seçmədir: hər iki qolda ümumilikdə 31 yeniyetmə.

Ailə, valideyn vasitəçiliyi, məktəbə bağlılıq və həyat tərzi tədbirləri geniş şəkildə tövsiyə olunur və uzununa qoruyucu amil məlumatları ilə uzlaşır — həmyaşıdlarla münasibətin keyfiyyəti r = −0,23, məktəbə bağlılıq r = −0,18, valideyn-övlad münasibəti r = −0,15, sosial dəstək r = −0,14 (Zhuang və b., 2023) — lakin onlar randomizə edilmiş sınaqlarda müstəqil müdaxilələr kimi yoxlanılmamışdır. Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün komendant saatı və həftəlik vaxt limitləri kimi milli tənzimləyici tədbirlər bir sıra ölkələrdə mövcuddur; onların klinik nəticələrə təsirinə dair heç bir yüksək keyfiyyətli qiymətləndirmə aşkar edilməmişdir və oyundaxili qumar qutularının (ing. loot box) və mikrotranzaksiyaların tənzimlənməsi açıq siyasət məsələsi olaraq qalır (Musetti və b., 2025).

8.5 Sübut səviyyələrinin xülasəsi

Müdaxilə	Səviyyə	Əsas məhdudiyyət
KDT, fərdi və qrup (STICA dozası: 15 qrup və səkkizə qədər fərdi seans)	ORTA	Çoxsaylı RKİ-lər, üstəgəl bir çoxmərkəzli RKİ; yüksək heterogenlik və təsdiqlənmiş nəşr yanlılığı; izləmə qazancları əhəmiyyətsiz
Qısamüddətli strukturlaşdırılmış abstinensiya	AŞAĞI	Yalnız bir pilot tədqiqat, 24 iştirakçı
Ailə-inteqrasiyalı yeniyetmə proqramları	AŞAĞI	Kiçik nəzarətli tədqiqat, ümumilikdə 31 yeniyetmə
Komorbid DDHP və ya depressiya üçün farmakoterapiya	AŞAĞI	12 sınaq, 724 iştirakçı, 98,6% kişi, hamısı Cənubi Koreyada, 12-dən 8-i açıq etiketli
Oyun oynama pozuntusunun özünə yönəlmiş farmakoterapiya	KİFAYƏTSİZ	Təsdiqlənmiş preparat yoxdur; komorbid olmayan, XBT-11 üzrə diaqnoz qoyulmuş seçmədə adekvat güclü plasebo nəzarətli sınaq yoxdur

Müdaxilə	Səviyyə	Əsas məhdudiyyət
Valideyn, məktəb və ətraf mühit tədbirləri	DOLAYI	Sınaqlarla deyil, uzununa risk amili məlumatları ilə dəstəklənir
Milli tənzimləyici məhdudiyyətlər	QİYMƏTLƏNDİRİLMƏMİŞDİR	Klinik nəticələrə dair heç bir yüksək keyfiyyətli qiymətləndirmə aşkar edilməmişdir

9. Proqnoz

Oyun oynama pozuntusuna dair proqnostik ifadələr bir-iki illik üfüqlə məhdudlaşdırılmalıdır. Bundan sonra heç nə məlum deyil: beş-on il davam edən heç bir izləmə tədqiqatı aşkar edilməmişdir, yeniyetmə yaşında başlayan oyun oynama pozuntusunun yetkinlik dövrü nəticələrinə dair məlumat yoxdur və mortalitə göstəriciləri üzrə məlumat yoxdur.

Təbii gedişat

Oyun oynama pozuntusu birmənalı şəkildə xroniki vəziyyət deyil. 50 uzununa tədqiqatın meta-analizi birillik izləmədə təxminən 43–45 faiz, iki ildə isə 34–38 faiz kateqoriya üzrə sabitlik aşkar etmişdir — bazada həddi ödəyənlərin üçdə biri ilə yarısı arasında olan hissə izləmədə də həmin həddi ödəyirdi, qalanları isə ödəmirdi. Simptomların ölçülən ağırlığı fərqli nəticə vermişdir: bazadan izləməyə korrelyasiyalar müsbət və statistik əhəmiyyətli olmuş, bu isə kateqorial status dəyişdiyi halda belə ağırlığın orta və yüksək davamlılığını göstərmişdir. Bu tərtibli stabillik şəxsiyyət pozuntusu və qumar oynama pozuntusununkinə bənzəyir, şizofreniya və ya bipolyar pozuntununkindən isə aşağıdır (Sun və b., 2025). Bu rəqəmlərlə birlikdə iki qeyd-şərt verilməlidir: birləşdirilmiş seçmələr üstünlüklə yeniyetmələrdən ibarət olmuşdur və bunlar müalicə olunmamış təbii gedişata dair məlumatlardır.

279 iştirakçının birillik uzununa tədqiqatı eyni istiqamətə işarə edir: il ərzində 34,7 faizdə DSM-5 İOP diaqnozu dəyişmiş, XBT-11 üzrə oyun oynama pozuntusu hallarının nisbəti isə 60,4 faizə qalxmışdır; iki sistemdə diaqnostik dəyişikliyin miqdarı arasında əhəmiyyətli fərq olmamışdır (Hong və b., 2023).

Prediktorlar

Patoloji oyunun inkişafı üçün prospektiv risk amilləri daha çox oyun oynama, daha aşağı sosial səriştə və daha yüksək impulsivlikdir (Gentile və b., 2011). Daha yüksək

simptom trayektoriyalarının meta-analitik uzununa prediktorları oyun vaxtı (r = 0,33), təklik hissi (r = 0,29), müşayiət edən sosial şəbəkə pozuntusu (r = 0,24), aqressiya (r = 0,23) və təşvişdir (r = 0,21); qoruyucu prediktorlar özünəkontrol (r = −0,27), vicdanlılıq (r = −0,25), həmyaşıdlarla münasibətin keyfiyyəti (r = −0,23), özünəqiymət (r = −0,19) və məktəbə bağlılıqdır (r = −0,18) (Zhuang və b., 2023). Birillik tədqiqatda diaqnostik dəyişiklik üçün ən yüksək şans nisbəti DDHP-də müşahidə edilmişdir (Hong və b., 2023).

Uğurlu müalicədən sonra residiv prediktorları müəyyən edilməmişdir. etibarlılığı yoxlanılmış residiv prediktoru mövcud deyil; bu isə o deməkdir ki, remissiyadan sonrakı izləmə yüksək riskli altqrupa hədəflənə bilməz və rutin əsasda təklif olunmalıdır.

Pozuntuya aid edilə bilən nəticələr

Sinqapurun ikiillik panelində depressiya, təşviş, sosial təşviş pozuntusu və daha aşağı məktəb müvəffəqiyyəti patoloji oyunun səbəbləri kimi deyil, nəticələri kimi çıxış etmişdir. Patoloji oyunçu olmağı dayandıran gənclər patoloji oyunçu olaraq qalanlara nisbətən daha aşağı depressiya, təşviş və sosial təşviş pozuntusu səviyyələri göstərmişlər (Gentile və b., 2011). Bu, sənədləşdirilmiş şəxsdaxili yaxşılaşma deyil, qruplararası müqayisədir və məktəb müvəffəqiyyətinin dayandıranlarla dayandırmayanlar arasında fərqləndirdiyi bildirilən dəyişənlər sırasında deyil. Bu, vəziyyətin sadəcə psixoloji sıxıntı ilə birgə mövcud olması deyil, prospektiv zərər daşıması barədə mövcud ən güclü sübut olaraq qalır.

Müalicə fonunda proqnoz

STICA çoxmərkəzli sınağında remissiya müalicə alan kişilərin 69,4 faizində, gözləmə siyahısı nəzarətinin isə 23,9 faizində baş vermişdir (Wölfling və b., 2019). Qeyri-farmakoloji müdaxilələrin meta-analizi daha yaşlı pasiyentlərin yeniyetmələrdən əhəmiyyətli dərəcədə daha çox yaxşılaşdığını aşkar etmişdir (g = −1,14, yeniyetmələrdə −0,45); bu yaş qradiyenti daha gənc pasiyentlərdə proqnostik gözləntiləri mülayimləşdirməlidir (Ock və b., 2025). Buna qarşı, KDT meta-analizi izləmə mərhələsində müalicə qazanclarını dörd nəticənin hamısı üzrə əhəmiyyətsiz hesab etmişdir (Stevens və b., 2019): qısamüddətli cavab yaxşı sənədləşdirilib, davamlılıq isə yox.

Proqnostik sübutda kimlər yoxdur

Qadınlar və qızlar müalicə ədəbiyyatında praktiki olaraq təmsil olunmurlar. Yeganə çoxmərkəzli randomizə edilmiş sınağa yalnız kişilər cəlb edilmiş, bütün farmakoloji ədəbiyyatda isə iştirakçıların 98,6 faizi kişi olmuşdur. Dərc edilmiş sübutlar əsasında qadın pasiyentlərdə müalicəyə cavab və ya proqnoz barədə heç bir fikir söyləmək

mümkün deyil və bu, kişi seçmələrindən alınmış rəqəmlərin arxasında gizlədilməkdənsə, qadın pasiyentlərə və onların ailələrinə bildirilməlidir.

10. Mif və yanlış inanclar

Gündəlik miflər və yanlış təsəvvürlər

Mif 1: «Çox oynayan hər kəs asılıdır»

Təkzib edilmişdir. XBT-11 heç vaxt həddi ehtiva etmir; diaqnoz kontrolun pozulmasını, digər həyati maraqların sıxışdırılmasını, zərərə baxmayaraq davam etməni *və* funksional pozulmanı tələb edir. ÜST (WHO) bildirir ki, oyun oynama pozuntusu rəqəmsal oyun və ya videooyunla məşğul olan insanların yalnız kiçik bir hissəsinə təsir edir. Yeni bir icmalda təqdim edilən şəxsə yönəlmiş tədqiqat gündə dörd saatdan çox oynayan və aşağı səviyyədə psixoloji uyğunsuzluq göstərən «ehtiraslı oyunçular» altqrupunu müəyyən etmişdir (Musetti və b., 2025; Billieux və b., 2019).

Mif 2: «Oyun oynama pozuntusu oyunçuların böyük hissəsinə təsir edir»

Yuxarı həddə üzrə təkzib edilib. Ən yüksək keyfiyyətli qiymətlər reprezentativ seçmələrdə 2,4 faiz və nəşr yanlılığına düzəlişdən sonra 1,4 faizdir (Kim və b., 2022); ağır hallar altqrupunda 1,96 faiz (95% ET 0,19–17,12) (Stevens və b., 2021); dörd iri beynəlxalq seçmədə DSM-5 meyarları ilə 0,3–1,0 faiz (Przybylski və b., 2017).

Mif 3: «Gündə müəyyən sabit saat sayı pozuntunu müəyyən edir»

Təkzib edilib. XBT-11 vəziyyəti davranış kontrolunun pozulması, oyunun digər maraqlar üzərində üstünlük təşkil etməsi, zərərə baxmayaraq davam etmə və funksional pozulma ilə müəyyən edir. Vaxt prospektiv risk amilidir ($r = 0,33$; Zhuang və b., 2023), lakin meyar deyil və nə zəruri, nə də kifayət deyil.

Mif 4: «Videooyunlar zorakılığa səbəb olur»

Səbəb əlaqəsi ilə bağlı iddia təkzib edilmişdir. Amerika Psixoloji Assosiasiyasının (American Psychological Association, APA) 2020-ci ilin fevral tarixli qətnaməsinin yenilənməsində bildirilir ki, zorakı videooyunlarla zorakı davranış arasında səbəb əlaqəsini dəstəkləyəcək elmi sübutlar kifayət etmir; orada zorakılığın, o cümlədən kütləvi atışmaların videooyun istifadəsinə aid edilməsinə qarşı açıq şəkildə xəbərdarlıq edilir. APA-nın 2015-ci il işçi qrupu hesabatına əsaslanan məlumatların yenidən təhlili aqressiv və prososial davranışla cüzi, aqressiv affekt və koqnisiyalarla kiçik, desensitizasiya ilə isə daha güclü əlaqələr aşkar etmişdir; effekt ölçüləri

xüsusilə eksperimental tədqiqatlarda qeyri-optimal tədqiqat praktikaları və tədqiqatçı gözləntisi effektləri (experimenter expectancy effects) hesabına yüksəlmiş görünürdü (Ferguson və b., 2020). Desensitizasiya tapıntısı ümumi arqumentə ziddir və məhz bu səbəbdən burada verilir. Zorakılıq və oyun oynama pozuntusu ayrı məsələlərdir və birləşdirilməməlidir.

Mif 5: «Oyun oynama pozuntusu depressiyanın və ya DDHP-nin simptomundan başqa bir şey deyil»

Qismən doğrudur və həqiqətən mübahisəlidir. Komorbidlik yüksəkdir və ən ardıcıl assosiasiyanı DDHP göstərir ($r \approx 0{,}30$; Koncz və b., 2023); tənqidçilər iddia edirlər ki, pozulmuş oyun davranışı əsasən affektiv və diqqət problemlərinə nisbətən ikinci dərəcəlidir (van Rooij və b., 2018). Buna qarşı, Sinqapurun ikiillik paneli depressiya, təşviş və sosial fobiyanın patoloji oyunun səbəbi kimi deyil, nəticəsi kimi çıxış etdiyini aşkar etmişdir (Gentile və b., 2011). Hər iki oxunuş təqdim edilməlidir; məsələ həll olunmayıb.

Mif 6: «Bütün oyunlardan tam abstinensiya yeganə düzgün müalicə məqsədidir»

Sübut olunmamışdır. Qısamüddətli könüllü abstinensiya yalnız pilot səviyyəsində dəstəyə malikdir (King və b., 2017) və adekvat gücə malik heç bir sınaq abstinensiyanı nəzarətli istifadə məqsədləri ilə müqayisə etməmişdir. Müalicə məqsədi fərdiləşdirilməlidir.

Mif 7: «Oyun oynama pozuntusunu sağaldan dərman var»

Təkzib edilmişdir. Heç bir dərman bu göstəriş üzrə tənzimləyici təsdiqə malik deyil; bütün farmakoloji ədəbiyyat 12 sınaqdan, 724 iştirakçıdan ibarətdir, iştirakçıların 98,6 faizi kişidir, sınaqların hamısı Cənubi Koreyada aparılmışdır və 12 sınaqdan 8-i açıq etiketli (open-label) olmuşdur (Sá və b., 2023). Dərmanlar komorbid DDHP və ya depressiya üçün etiketdən kənar (off-label) istifadə olunur.

Mif 8: «Oyun qutuları (ing. loot box) və oyundaxili alışlar zərərsiz əyləncədir»

Təkzib edilmişdir. 7 422 oyunçuda oyun qutusu (ing. loot box) xərcləri problemli qumar şiddəti ilə assosiasiya olunmuşdur ($\eta^2 = 0{,}054$); bu effekt digər oyundaxili alışlar üçün olan effektdən ($\eta^2 = 0{,}004$) təqribən on dəfə böyükdür (Zendle və Cairns, 2018). Sübutlar en kəsiyi (cross-sectional) xarakterlidir və heç bir istiqamətdə səbəb əlaqəsi müəyyən etmir, lakin assosiasiya hər qiymətləndirmədə bu barədə məlumat soruşulmasını əsaslandıracaq qədər möhkəmdir.

Mif 9: «Oyun oynama pozuntusu Asiya problemidir»

Şişirdilmişdir. Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya seçmələrindən alınan yayılma qiymətləri daha yüksək olmağa meyllidir, lakin ən geniş meta-analizdə skrininq aləti tədqiqatlararası variasiyanın 77 faizini izah etmiş və region bildirilən əhəmiyyətli prediktorlar sırasına daxil edilməmişdir (Stevens və b., 2021); Kim və b. (2022) regionu bir neçə moderatordan biri kimi sadalayır. Region alət, seçmə tipi və tədqiqat keyfiyyəti ilə qarışdırıcı şəkildə bağlıdır və hallar dünyanın hər yerində bildirilir.

Mif 10: «Oyun və depressiya üzrə ədəbiyyat möhkəmdir»

Təkzib edilmişdir. Oyun oynama pozuntusunun depressiya və ya təşvişlə əlaqəsinə dair yeddi sistematik icmalın — 196 ilkin tədqiqatı əhatə edən — qiymətləndirilməsi onların hamısında nəticələrin seçmə bildirilməsini, yalnız birində yanlılıq riskinin qiymətləndirilməsini və ardıcıl olmayan məruzqalma (ekspozisiya, exposure) tərifləri aşkar etmişdir; heç biri etibarlı kimi təsnif edilməmişdir (Colder Carras və b., 2020).

Kateqoriyanın özü ətrafında elmi mübahisə

6C51 XBT-11-in asılılıq davranışları ilə əlaqədar pozuntular (6C50–6C5Z) qrupundakı ən mübahisəli diaqnozdur. Mübahisə akademikdir, kommersiya xarakterli deyil və onun geniş yayılmış hər iki izahı — bir tərəfdən sənaye lobbiçiliyi, digər tərəfdən sırf əxlaqi panika (moral panic) — səhvdir.

Daxil edilməyə qarşı arqumentlər aşağıdakılardır. 2017-ci ildə 26 alim ÜST-ün (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı) təklifinə qarşı açıq mübahisə məqaləsi dərc etmişdir (Aarseth və b., 2017). Onların arqumentləri belə idi: tədqiqat bazası aşağı keyfiyyətlidir; operasionallaşdırma maddə istifadəsi və qumar meyarlarından tənqidsiz götürülmüşdür; diaqnoz normal, sağlam, intensiv oyunu patologiyalaşdırmaq riski daşıyır; və rəsmiləşdirmə mənəvi panikanı qidalandıra, geniş əhali qrupunu damğalaya və uşaqların lazımsız müalicəsinə gətirib çıxara bilər. Qismən üst-üstə düşən qrup daha sonra irəli sürdü ki, tədqiqat konstruktundan formal pozuntuya keçid üçün tələb olunan sübut həcmi çox böyükdür — məhz ona görə ki, diaqnozlardan sui-istifadə edilə bilər — və WHO rəsmiləşdirməni təxirə salmalıdır (van Rooij və b., 2018).

Daxil edilmənin lehinə arqumentlər aşağıdakılardır. ÜST ekspert məsləhətləşməsinin nəticələrinə əsasən belə əsaslandırılırdı ki, oyun oynama pozuntusu asılılıq pozuntusunun əsas əlamətlərini nümayiş etdirir və artıq müalicəyə müraciət edən insanlar üçün kateqoriya zəruridir (Saunders və b., 2017). Rumpf və həmkarları klinik və ictimai səhiyyə mövqeyindən cavab verdilər: bu pasiyentlər üçün müalicə xidmətləri bir çox ölkədə artıq mövcud idi; kateqoriya olmadan

pasiyentləri etibarlı şəkildə müəyyən etmək, xidmətləri planlaşdırmaq və maliyyələşdirmək, tədqiqatı standartlaşdırmaq mümkün deyildi; həddindən artıq diaqnoz riski isə XBT-11-in ciddi pozulma tələbi ilə yumşaldılır (Rumpf və b., 2018). Griffiths və həmkarları iddia etdilər ki, problemli oyun sübut olunan şəkildə mövcuddur və pozulmuş oyun davranışının nümunəsidir (Griffiths və b., 2017).

ÜST-ün mövqeyi. WHO kateqoriyanı saxladı, daxil edilməni dünyanın bir çox yerində eyni klinik təzahürlər üçün müalicə proqramlarının müstəqil şəkildə inkişaf etməsinin təbii nəticəsi kimi təqdim etdi və ictimai təlimatında vurğuladı ki, oyun oynama pozuntusu oyun oynayan insanların yalnız kiçik bir hissəsinə təsir edir — bu, həddindən artıq patologiyalaşdırma ilə bağlı etirazı nəzərə almağa yönəlmiş addım kimi şərh edilə bilər.

Sənayenin mövqeyi. Geniş yayılmış fərziyyənin əksinə olaraq, videooyun sənayesi diaqnoza qarşı çıxdı. Əyləncə Proqram Təminatı Assosiasiyası (ing. Entertainment Software Association) asılılıq çərçivəsini açıq şəkildə rədd etmişdir və ÜST-ü istiqaməti dəyişməyə çağırmışdır; oxşar narahatlıqlar Avropa Oyun Tərtibatçıları Federasiyası (ing. European Games Developer Federation) tərəfindən də səsləndirilmişdir (Musetti və b., 2025-də bildirilir). Diaqnozu sənaye lobbiçiliyinə aid etmək olmaz, mənəvi panika etirazı isə sənayedən deyil, akademik mühitin özündən gəlmişdir.

Həqiqətən həll olunmamış məsələlər bunlardır. Üç şey — hər biri həkimin pasiyentə deyəcəyini dəyişir. XBT-11 təlimatlarının qiymətləndiricilərarası etibarlılığı bir dəfə, bir ölkədə, bir məktəb əsaslı seçmədə yoxlanılmış və orta səviyyədə olmuşdur ($\kappa = 0{,}545$). Kateqoriyal status hər iki diaqnostik sistemdə bir il ərzində qeyri-sabitdir. Ən geniş yayılmış komorbidliklərə dair sintez ədəbiyyatı isə qəbul edilmiş metodoloji standartlara cavab vermir. Bunların heç biri diaqnozu yararsız etmir; hamısı isə etibarlı proqnozu əsassız edir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11 Ölüm və Xəstələnmə Statistikası: 6C51 Oyun pozuntusu. Cenevrə: ÜST; 2019 (2025-01 buraxılışı).
2. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Ölüm və Xəstələnmə Statistikası üzrə XBT-11: QE22 Təhlükəli oyun. Cenevrə: ÜST; 2019 (2025-01 buraxılışı).
3. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11 üzrə psixi, davranış və neyroinkişaf pozuntularının klinik təsvirləri və diaqnostik tələbləri (CDDR). Cenevrə: ÜST; 2024.
4. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Asılılıq davranışları: Oyun pozuntusu — suallar və cavablar. Cenevrə: ÜST.

5. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təsnifatı, beşinci nəşr, mətn yenidən işlənmiş (DSM-5-TR). Vaşinqton, DC: Amerika Psixiatriya Assosiasiyası Nəşriyyatı; 2022. (İnternet oyun pozuntusu — III Bölmə, Sonrakı Tədqiqat üçün Şərtlər.)
6. Amerika Psixologiya Assosiasiyası (APA). Zorakı video oyunları haqqında APA qətnaməsi: fevral 2020-ci il redaktəsi. Vaşinqton, DC: APA; 2020.
7. Amerika Psixologiya Assosiasiyası (APA). Zorakı video oyunları və zorakı davranış barədə APA öz mövqeyini təsdiqləyir [mətbuat relizi]. 3 mart 2020.
8. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Qumarla əlaqəli zərərlər: müəyyənləşdirmə, qiymətləndirmə və idarəetmə. NICE təlimatı NG248. London: NICE; 28 yanvar 2025. (Müqayisə üçün göstərilir: oyun pozuntusu üçün NICE təlimatı mövcud deyil.)
9. Aarseth E., Bin A.M., Bonen H., Kolder Karras M., Koulson M., Das D. və b. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının XBT-11 Oyun Pozuntusu təklifi barədə alimlərin açıq müzakirə sənədi. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2017;6(3):267–270. https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.088
10. Billiö C., Flayel M., Rumpf H.C., Stein D.C. Video oyunlarda yüksək məşğulluq patoloji məşğulluqdan fərqlidir: oyun pozuntusunun etibarlılığının və faydalılığının təmin edilməsi üçün həlledici fərq. «Müasir Asılılıq Hesabatları» (Curr Addict Rep). 2019;6(3):323–330. https://doi.org/10.1007/s40429-019-00259-x
11. Brand M., Yanq K.S., Layer C., Völflinq K., Potenza M.N. İnternet istifadəsi ilə bağlı spesifik pozuntuların inkişafı və davam etməsi barədə psixoloji və neyrobioloji mülahizələrin inteqrasiyası: Şəxs–Affekt–Koqnisiya–İcra (I-PACE) modeli. «Neyrobiologiya və Davranış Rəyləri» (Neurosci Biobehav Rev). 2016;71:252–266. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.08.033
12. Brand M., Vekmann E., Stark R., Müller A., Völflinq K., Robbins T.V., Potenza M.N. Asılılıq davranışları üçün Şəxs–Affekt–Koqnisiya–İcra (I-PACE) modeli: yenilənmə, internet istifadəsi pozuntularından kənar asılılıq davranışlarına ümumiləşdirmə və asılılıq davranışlarının proses xarakterinin dəqiqləşdirilməsi. «Neyrobiologiya və Davranış Rəyləri» (Neurosci Biobehav Rev). 2019;104:1–10. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.032
13. Kolder Karras M., Şi C., Hard G., Saldanha İ.C. Oyun pozuntusu üçün sübutların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi: oyun pozuntusu ilə depressiya və ya təşviş arasındakı əlaqələrə dair sistematik icmalların xülasəsi. «PLoS One». 2020;15(10):e0240032. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240032
14. Danielsen P.A., Mentsoni R.A., Loq T. Oyun pozuntusu üçün terapevtik müdaxilələrin müalicə effektləri: sistematik icmal və meta-analiz. «Asılılıq

Davranışları» (Addict Behav). 2024;149:107887. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2023.107887 (PMID 37826910)

15. Ferguson K.C., Kopenheyver A., Marki P. Amerika Psixologiya Assosiasiyasının zorakı media üzrə 2015-ci il işçi qrupunun nəticələrinin yenidən araşdırılması: meta-analiz. «Psixologiya Elmində Perspektivlər» (Perspect Psychol Sci). 2020;15(6):1423–1443. https://doi.org/10.1177/1745691620927666
16. Centile D.A., Çu H., Liau A., Sim T., Li D., Funq D., Ku A. Yeniyetmələr arasında patoloji video oyun istifadəsi: ikiillik uzununa tədqiqat. «Pediatriya» (Pediatrics). 2011;127(2):e319–e329. https://doi.org/10.1542/peds.2010-1353
17. Centile D.A., Beyli K., Bavelier D., Brokmayer C.F., Keş H., Koyn S.M. və b. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə internet oyun pozuntusu. «Pediatriya» (Pediatrics). 2017;140(Suppl 2):S81–S85. https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758H
18. Griffits M.D., Kuss D.C., Lopes-Fernandes O., Pontes H.M. Problematik oyun mövcuddur və o, pozulmuş oyunun nümunəsidir. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2017;6(3):296–301. https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.037
19. Han D.H., Renşou P.F. Bupropionun böyük depressiv pozuntulu xəstələrdə problemli onlayn oyun oynamanın müalicəsində tətbiqi. «Psixofarmakologiya Jurnalı» (J Psychopharmacol). 2012;26(5):689–696. https://doi.org/10.1177/0269881111400647 (PMID 21447539)
20. Xonq Y.N., Hvanq H., Starçeviç V., Çoy T.Y., Kim T.H., Han D.H. Hansı daha sabit və spesifikdir: DSM-5 internet oyun pozuntusu, yoxsa XBT-11 oyun pozuntusu? Uzununa tədqiqat. «Psixiatriya və Klinik Neyroelmlər» (Psychiatry Clin Neurosci). 2023;77(4):213–222. https://doi.org/10.1111/pcn.13522 (PMID 36562926)
21. Kardefelt-Vinter D. İnternet asılılığı tədqiqatlarının konseptual və metodoloji tənqidi: kompensasiyaedici internet istifadəsi modelinə doğru. «Kompüterlər və İnsan Davranışı» (Comput Human Behav). 2014;31:351–354. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.059
22. Kim H.S., Son G., Ro E.B., Ahn V.Y., Kim C., Şin S.H., Çey C., Çoy K.H. Oyun pozuntusunun yayılması: meta-analiz. «Asılılıq Davranışları» (Addict Behav). 2022;126:107183. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107183 (PMID 34864436)
23. Kinq D.L., Billiö C., Karraher N., Delfabbro P.H. Oyun pozuntusu üçün skrininq alətlərinin üz etibarlılığının qiymətləndirilməsi: əhatə dairəsi, dil və həddindən artıq patologiyalaşdırma məsələləri. «Davranış Asılılıqları

Jurnalı» (J Behav Addict). 2020;9(1):1–13. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00001 (PMID 32359228)

24. Kinq D.L., Kaptsis D., Delfabbro P.H., Gradisar M. Problemli internet oyunu koqnisiyalarını və davranışlarını dəyişdirmək üçün qısa abstinensiyanın effektivliyi. «Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Clin Psychol). 2017;73(12):1573–1585. https://doi.org/10.1002/jclp.22460 (PMID 28152189)
25. Kiraly O., Sleçka P., Pontes H.M., Urban R., Griffits M.D., Demetroviç Z. On bəndlik İnternet Oyun Pozuntusu Testinin (IGDT-10) etibarlılıq yoxlanışı (validasiya) və DSM-5-in doqquz İnternet Oyun Pozuntusu meyarının qiymətləndirilməsi. «Asılılıq Davranışları» (Addict Behav). 2017;64:253–260. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.005
26. Kiraly O., Böte B. və b. On bəndlik İnternet Oyun Pozuntusu Testi (IGDT-10): ölçmə invariantlığı və yeddi dil əsaslı nümunə üzrə mədəniyyətlərarası etibarlılıq yoxlanışı. «Psixologiya və Asılılıq Davranışı» (Psychol Addict Behav). 2019;33(1):91–103. https://doi.org/10.1037/adb0000433
27. Konç P., Demetroviç Z., Takaç Z.K., Griffits M.D., Nagy T., Kiraly O. DDHP simptomları ilə oyun pozuntusu arasındakı əlaqəyə dair yeni sübutlar: sistematik icmal və meta-analiz. «Klinik Psixologiya İcmalları» (Clin Psychol Rev). 2023;106:102343. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2023.102343 (PMID 37883910)
28. Kuss D.C., Griffits M.D., Pontes H.M. DSM-5-də İnternet Oyun Pozuntusu diaqnozunda xaos və çaşqınlıq. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2017;6(2):103–109. https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.062
29. Ma C., Vanq Z., Li C., Lu C., Lonq C., Li R., Vu K., Cianq H., Du C., Li R., Vanq P., Ma L., Li H., Xuy S., Jao V., Jonq N., Jao M. XBT-11-in oyun pozuntusu üzrə diaqnostik təlimatlarının klinik ardıcıllığı və faydalılığı: Çin əhalisi arasında sahə tədqiqatı. «Psixiatriyada Sərhədlər» (Front Psychiatry). 2021;12:781992. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.781992 (PMID 35002801; 781992 — məqalə nömrəsi)
30. Müller S.M., Vekmann E., Oelker A., Stark R., Müller A., Montak K., Völflinq K., Rumpf H.C., Brand M. Xüsusi İnternet İstifadəsi Pozuntuları üzrə Meyarların Qiymətləndirilməsi (ACSID-11): XBT-11-in oyun pozuntusu və digər potensial internet istifadəsi pozuntuları üzrə meyarlarını əhatə edən yeni skrininq alətinin təqdimatı. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2022;11(2):427–450. https://doi.org/10.1556/2006.2022.00013
31. Musetti A., Floros G., Kiappedi M., Stavropulos V. XBT-11-də oyun pozuntusu: oyunun mövcud vəziyyəti. «BMC Psixiatriyası» (BMC

Psychiatry). 2025;25(1):1114. https://doi.org/10.1186/s12888-025-07576-8 (PMID 41272537; 1114 — məqalə nömrəsi)

32. Nam B., Bae S., Kim S.M., Honq C.S., Han D.H. Bupropion və essitalopramın əsas depressiv pozuntusu olan xəstələrdə həddindən artıq internet oyununa təsirinin müqayisəsi. «Klinik Psixofarmakologiya və Nevrologiya» (Clin Psychopharmacol Neurosci). 2017;15(4):361–368. https://doi.org/10.9758/cpn.2017.15.4.361
33. Ok C.M., Li H.S., Çe C., Kim H. Oyun pozuntusuna qeyri-farmakoloji müdaxilələrin effektivliyi: sistematik icmal və meta-analiz. «Psixiatriya Tədqiqatları» (Psychiatry Investig). 2025;22(5):490–503. https://doi.org/10.30773/pi.2024.0358
34. Paruti S., Bruks L.C., D'Ambrosio K., Holl V.A., Kotaqal S., Lloyd R.M. və b. Pediatrik populyasiyalar üçün tövsiyə olunan yuxu miqdarı: Amerika Yuxu Təbabəti Akademiyasının konsensus bəyanatı. «Klinik Yuxu Təbabəti Jurnalı» (J Clin Sleep Med). 2016;12(6):785–786. https://doi.org/10.5664/jcsm.5866
35. Paulus F.V., Oman S. fon Qontard A., Popov K. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə internet oyun pozuntusu: sistematik icmal. «İnkişaf Təbabəti və Uşaq Nevrologiyası» (Dev Med Child Neurol). 2018;60(7):645–659. https://doi.org/10.1111/dmcn.13754
36. Pontes H.M., Qriffits M.D. DSM-5 internet oyun pozuntusunun ölçülməsi: qısa psixometrik şkalanın hazırlanması və etibarlılıq yoxlanışı. «Kompüterlər və İnsan Davranışı» (Comput Human Behav). 2015;45:137–143. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.006
37. Pontes H.M., Şivinski B., Zindermann C., Li M., Bekker B., Jou M., Montaq K. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) çərçivəsinə uyğun olaraq Oyun Pozuntusunun ölçülməsi və konseptuallaşdırılması: Oyun Pozuntusu Testinin hazırlanması. «Beynəlxalq Ruhi Sağlamlıq və Asılılıq Jurnalı» (Int J Ment Health Addict). 2021;19(2):508–528. https://doi.org/10.1007/s11469-019-00088-z
38. Pun L.Y.C., Tsanq H.V.H., Çan T.Y.C., Man S.V.T., Nq L.Y., Vonq Y.L.E., Lin K.Y., Çien K.V., Qriffits M.D., Pontes H.M., Pakpur A.H. İnternet Oyun Pozuntusu Şkalasının Qısa Formasının (IGDS9-SF) psixometrik xassələri: sistematik icmal. «Tibbi İnternet Tədqiqatları Jurnalı» (J Med Internet Res). 2021;23(10):e26821. https://doi.org/10.2196/26821
39. Pşibılski A.K., Vaynşteyn N., Murayama K. İnternet oyun pozuntusu: yeni fenomenin klinik əhəmiyyətinin araşdırılması. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2017;174(3):230–236. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.16020224

40. Cahrami H., Husayn V., Lin K.-Y. və b. Oyun Pozuntusu Testinin (GDT) etibarlılığının ümumiləşdirilməsi meta-analizi və psixometrik icmalı: daxili ardıcıllığın qiymətləndirilməsi. «Asılılıq Davranışı Hesabatları» (Addict Behav Rep). 2024;20:100563.
41. Ropovik İ., Martonçik M., Babinçak P., Banik Q., Varqova L., Adamkoviç M. (İnternet) oyun pozuntusu üçün risk və qoruyucu amillər: COVID-dən əvvəlki tədqiqatların meta-analizi. «Asılılıq Davranışları» (Addict Behav). 2023;139:107590. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107590
42. Rumpf H.Y., Açab S., Bilyo J., Bouden-Cons H., Karraher N., Demetroviks Z. və b. Oyun pozuntusunun XBT-11-ə daxil edilməsi: klinik və ictimai səhiyyə baxımından bunun zəruriliyi. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2018;7(3):556–561. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.59
43. Sa R.R.C., Kuelo S., Parmar P.K., Constoun S., Kim H.S., Tavares H. İnternet Oyun Pozuntusunun farmakoloji müalicəsinin sistematik icmalı. «Psixiatriya Tədqiqatları» (Psychiatry Investig). 2023;20(8):696–706. https://doi.org/10.30773/pi.2022.0297
44. Satiş Kumar C.R., Şarma M.K., Amudhan S., Arya S., Mahapatra S., Anand N. və b. Rəqəmsal oyun, dayaq-hərəkət sistemi və əlaqəli sağlamlıq riskləri yeniyetmələr və gənc böyüklər arasında. «Hindistan Psixiatriya Jurnalı» (Indian J Psychiatry). 2023;65(6):698–700. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_818_22
45. Saunders C.B., Hao V., Lonq C., Kinq D.L., Mann K., Faut-Bühler M. və b. Oyun pozuntusu: diaqnoz, idarəetmə və profilaktika (qarşısının alınması) üçün mühüm vəziyyət kimi təyini. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2017;6(3):271–279. https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.039
46. Stevens M.V., Dorstin D., Delfabbro P.H., Kinq D.L. Oyun pozuntusunun qlobal yayılması: sistematik icmal və meta-analiz. «Avstraliya və Yeni Zelandiya Psixiatriya Jurnalı» (Aust N Z J Psychiatry). 2021;55(6):553–568. https://doi.org/10.1177/0004867420962851
47. Stevens M.V., Dorstin D., Delfabbro P.H., Kinq D.L. Düzəliş: Oyun pozuntusunun qlobal yayılması: sistematik icmal və meta-analiz. «Avstraliya və Yeni Zelandiya Psixiatriya Jurnalı» (Aust N Z J Psychiatry). 2023;57(6):928. https://doi.org/10.1177/00048674221137011
48. Stevens M.V.R., Kinq D.L., Dorstin D., Delfabbro P.H. İnternet oyun pozuntusu üçün koqnitiv-davranış terapiyası: sistematik icmal və meta-analiz. «Klinik Psixologiya və Psixoterapiya» (Clin Psychol Psychother). 2019;26(2):191–203. https://doi.org/10.1002/cpp.2341
49. San A.P., Ho K.H., Kuss D.Y., Kross K.L. Problemli oyun və oyun pozuntusunun zaman üzrə sabitliyi: sistematik icmal və meta-analiz.

«Asılılıq Davranışı Hesabatları» (Addict Behav Rep). 2025;21:100592. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2025.100592

50. Torres-Rodriqes A., Qriffits M.D., Karbonell Ks., Oberst U. İnternet Oyun Pozuntusu üçün ixtisaslaşdırılmış psixoterapiya proqramının müalicə effektivliyi. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2018;7(4):939 –952. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.111
51. van Roy A.Y., Ferquson K.C., Kolder Karras M., Kardefelt-Vinther D., Şi C., Aarset E. və b. Oyun pozuntusu üçün zəif elmi əsas: ehtiyatlılıq tərəfini seçək. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2018;7(1):1–9. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.19
52. Vink Y.M. van Beysterveld T.C.E.M., Hupperts K., Bartels M., Boomsma D.İ. Yeniyetmələrdə kompulsiv internet istifadəsinin irsiyyəti. «Asılılıq Biologiyası» (Addict Biol). 2016;21(2):460–468. https://doi.org/10.1111/adb.12218
53. Völflinq K., Müller K.V., Drayer M., Rukes K., Doyşter O., Batra A. və b. İnternet və kompüter oyunlarından asılılığın qısamüddətli müalicəsinin effektivliyi: randomizə olunmuş klinik sınaq. «JAMA Psixiatriya» (JAMA Psychiatry). 2019;76(10):1018–1025. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.1676
54. Yanq K.S. İnternet asılılığı: yeni klinik pozuntunun meydana çıxması. «Kiberpsixologiya və Davranış» (CyberPsychology and Behavior). 1998;1(3):237–244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237
55. Zendl D., Kerns P. Video oyunu qənimət yeşikləri problemli qumarla bağlıdır: genişmiqyaslı sorğunun nəticələri. «İctimai Elmi Kitabxana» (PLoS One). 2018;13(11):e0206767. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206767
56. Zenq H., Hu Y., Vanq Z., Vanq M., Du Ks., Donq Q. İnternet oyun pozuntusu olan subyektlərdə funksional neyron dəyişikliklərin meta-analizləri: müxtəlif paradigmalar arasında oxşarlıqlar və fərqlər. «Neyropsixofarmakologiya və Bioloji Psixiatriyada Tərəqqi» (Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry). 2019;94:109656. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.109656
57. Juaq Ks., Jan Y., Tan Ks., Nq T.K., Lin C., Yan Ks. İnternet oyun pozuntusunun uzunmüddətli dəyişdirilə bilən risk və qoruyucu amilləri: sistematik icmal və meta-analiz. «Davranış Asılılıqları Jurnalı» (J Behav Addict). 2023;12(2):375–392. https://doi.org/10.1556/2006.2023.00017

6C70–6C7Z İMPULS NƏZARƏTİ POZUNTULARI

İmpuls nəzarəti pozuntuları (Impulse control disorders)

XBT-11 **6C70**	**6C70 PİROMANİYA** **Pyromania**
XBT-10 F63.1	XBT-10 / F63.1 || Patoloji yanğınsalma (piromaniya)
DSM-5-TR F63.1	Piromaniya

1. Tərif və nozologiya

Piromaniya (XBT-11: 6C70; DSM-5-TR: 312.33 (F63.1)) — qəsdli, məqsədli yanğın salma davranışı; aktdan əvvəl gərginlik və ya emosional həyəcan, aktdan sonra rahatlıq və ya zövq. Maliyyə qazancı, intiqam və ya ideoloji məqsəd olmadan baş verir; nadir impuls nəzarəti pozuntusudur.

2. Tarixçə

- Marc C.C.H. (1833) — «monomanie incendiaire» termini.
- DSM-III (1980) — impuls nəzarəti pozuntuları bölməsinə daxil edilmişdir.
- XBT-11 (2019) — impuls nəzarəti pozuntuları kateqoriyasına daxil edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Nadir — yanğın salma hadisələrinin yalnız təxminən 3–10%-i piromaniya meyarlarına çatır (əksər yanğınsalma maliyyə, intiqam və ya başqa motivasiya ilə bağlıdır).
- Cins: kişilərdə daha yüksəkdir.
- Başlanğıc: yeniyetməlik dövrünə təsadüf edir.
- Komorbidlik: davranış pozuntusu, ASP, İD, DDHP, digər maddə istifadəsi pozuntusu.

4. Etiologiya və patogenez

- Çoxsaylı amillər — neyrobioloji impuls nəzarəti, koqnitiv çatışmazlıq, ailə disfunksiyası.
- Komorbid pozuntular tipikdir.

5. Klinik təzahürlər

- Təkrarlanan qəsdli yanğın salma.
- Aktdan əvvəl gərginlik və ya affektiv həyəcan (bax: meyar B).
- Yanğına, atributlara (alov, alət) heyranlıq.
- Aktdan sonra zövq, rahatlıq.
- Maliyyə qazancı, intiqam, ideoloji məqsəd və ya psixotik motivasiya (sayıqlama) yoxdur.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Birdən çox qəsdli və məqsədli yanğın salma.

B. Aktdan əvvəl gərginlik və ya affektiv həyəcan.

C. Yanğına, onun atributlarına və situasiya kontekstinə heyranlıq.

D. Yanğın salarkən, onu müşahidə edərkən və ya nəticələrində iştirak edərkən zövq, rahatlıq və ya məmnunluq yaranır.

E. Yanğın maliyyə qazancı, intiqam, ideoloji və ya sosial-politik məqsəd, sayıqlama və ya halüsinasiya, yaxud mühakimənin pozulması ilə şərtlənmir.

F. Davranış pozuntusu, manik epizod, ASP ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR və XBT-11 meyarları eynidir.
- Klinik praktikada nadir; əksər yanğın salma halları motivasiyaya əsaslanır.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə, ailə və şahid məlumatları əsasında aparılır.
2. Motivasiya tarixçəsi piromaniya meyarlarına uyğunluq baxımından qiymətləndirilir.
3. Komorbidlik (ASP, davranış pozuntusu, manik, psixoz, İD, DDHP).

4. Hüquqi kontekstdə adli psixiatriya konsultasiyası tələb olunur.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Davranış pozuntusu (6C91)	Çoxsaylı antisosial davranış.
ASP (Antisosial şəxsiyyət)	Davamlı antisosial model.
Manik epizod	Affektiv epizodla əlaqəli.
Psixotik motivasiya	Sayıqlama və ya halüsinasiyalar (məs. «səslər»); şizofreniya və sayıqlama pozuntusu.
İntiqam / maliyyə / ideoloji	Klinik diaqnoz deyil — adli mövzu.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Psixiatrik müsahibə.
- İntellektual qiymətləndirmə.
- İmpulsivlik şkalaları (Barratt İmpulsivlik Şkalası, Barratt Impulsiveness Scale).
- Adli kontekstdə strukturlaşdırılmış risk qiymətləndirməsi (HCR-20 — Historical-Clinical-Risk Management-20; VRAG — Violence Risk Appraisal Guide).

8. Müalicə

1. Sübut bazası məhduddur (nadir pozuntu).
2. KDT — impuls nəzarəti, tətikləyicilərin idarəsi, ekspozisiya (məruz qalma) və alternativ davranışın formalaşdırılması.
3. Komorbid pozuntuların müalicəsi (ASP-də terapevtik məhdudiyyət, ID-də davranış müdaxiləsi, DDHP-də stimulyant).
4. SSGİ — impuls nəzarəti üçün off-label.
5. Hüquqi-psixiatrik koordinasiya (hospitalizasiya, məhkəmə qərarı).

8.1 Müalicə metodları

1. İmpuls nəzarəti üçün KDT — tətikləyicinin müəyyənləşdirilməsi, davranış əvəzləyicisi.
2. Komorbidlik müalicəsi — Davranış pozuntusu, İD (intellektual əlillik) və DDHP üçün spesifik müdaxilə.

3. Məhkəmə-psixiatrik risk qiymətləndirməsi — HCR-20, VRAG.

9. Proqnoz

- Sübut bazası məhduddur; proqnozu komorbid pozuntular və psixososial dəstək müəyyən edir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Bütün yanğınsalanlar piromaniyalıdır»

Sübut: yanğınsalma hallarının əksəriyyəti motivasiyaya əsaslanır (maliyyə, intiqam) — piromaniya deyil; təxminən 3–10% klinik diaqnoza uyğun.

Mif 2: «Piromaniya yalnız uşaqlarda rast gəlinir»

Sübut: Xəstəlik adətən yeniyetməlik dövründə başlayır, lakin yetkinlikdə də davam edə bilər.

Mif 3: «Spesifik effektiv farmakoterapiya var»

Sübut: FDA təsdiqi yoxdur; SSGİ təsdiqlənməmiş göstərişlə (off-label) tətbiq olunur; sübut bazası məhduddur.

Mif 4: «Yalnız hüquqi cəza kifayətdir»

Sübut: klinik müdaxilə və komorbidlik müalicəsi residiv riskini azaldır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C70 Piromaniya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Börton P.R., MakNeyl D.E., Baynder R.L. Od qoyma, kəsdirib-yandırma, piromaniya və məhkəmə psixi sağlamlıq eksperti. «Amerika Psixiatriya və Hüquq Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Psychiatry Law). 2012;40(3):355–365.

XBT-11 **6C71**	**6C71 KLEPTOMANİYA** **Kleptomania**
XBT-10 F63.2	Oğurluğa patoloji hərislik (kleptomaniya)
DSM-5-TR F63.2	Kleptomaniya

1. Tərif və nozologiya

Kleptomaniya (XBT-11: 6C71; DSM-5-TR: F63.2) — şəxsi istifadə və ya maliyyə dəyəri üçün lazım olmayan əşyaların oğurlanması üçün təkrarlanan müqavimət göstərə bilməyən impuls; aktdan əvvəl gərginlik, aktdan sonra isə rahatlıq və ya zövq hissi müşahidə olunur.

2. Tarixçə

- Esquirol (1838) — «kleptomanie».
- DSM-III — impuls nəzarəti pozuntuları.
- XBT-11 — impuls nəzarəti pozuntuları.

3. Epidemiologiya

- Mağaza oğurluğu hadisələrinin yalnız təxminən 5%-i kleptomaniyaya uyğundur (əksər oğurluq motivasiyaya əsaslanan).
- Cins: kişilərlə müqayisədə qadınlarda daha yüksəkdir (klinik nümunələrdə).
- Komorbidlik: əhval pozuntuları müxtəlif tədqiqat silsilələrində 45–100%, TDP təxminən 65%-ə qədər; narahatlıq, OKP, yemə pozuntuları, maddə istifadəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- Serotonin və opioid sistemlərinin dizrequlyasiyası hipotezi (Grant J.E.).
- Komorbid affektiv və impulsivlik pozuntuları.

5. Klinik təzahürlər

- Oğurluq aktına müqavimət göstərmə uğursuzluğu — şəxsi və ya maliyyə dəyəri üçün lazım olmayan əşya.

- Aktdan əvvəl gərginlik artımı.
- Aktdan sonra rahatlıq, zövq.
- Oğurluq qəzəb, intiqam və ya psixotik motivasiya ilə deyil.
- Əşyalar tipik olaraq sonradan atılır, gizlədilir və ya gizlicə geri qaytarılır.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Şəxsi və ya maliyyə dəyəri üçün lazım olmayan əşyaları oğurlamağa təkrarlanan müqavimət göstərə bilməyən impuls.

B. Aktdan əvvəl gərginlik.

C. Aktdan sonra rahatlıq, zövq.

D. Oğurluq qəzəb, intiqam, sayıqlama və ya hallüsinasiyaya cavab olaraq törədilmir.

E. Davranış pozuntusu, manik epizod, ASP ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

DSM-5-TR / XBT-11 — eyni meyarlar.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Kleptomaniya Simptomlarının Qiymətləndirilməsi Şkalası (ing. Kleptomania Symptom Assessment Scale, K-SAS) — Grant J.E.
3. Komorbid TDP, narahatlıq, OKP, yemə pozuntuları.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Adi oğurluq	Motivasiya — qazanc, ehtiyac.
ASP	Davamlı antisosial model.
Manik epizod	Affektiv kontekst.
Davranış pozuntusu (6C91)	Çoxsaylı antisosial davranış.
Demensiya	Koqnitiv funksiyaların azalması.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- K-SAS.
- Komorbidlik şkalaları.

8. Müalicə

1. Naltrekson — Grant J.E. və b. Biol Psychiatry 2009 RKİ — kleptomaniyada təsir (Qrant C.E. və b., 2009; 50–150 mq/gün).
2. KDT — koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, davranış aktivasiyası, ekspozisiya və ritualların qarşısının alınması.
3. SSGİ — komorbid TDP üçün.
4. Multidissiplinar yanaşma — hüquqi kontekst.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Naltrekson — opioid antaqonisti; kleptomaniyada oğurlama istəyini (craving) azaldır.
2. İmpuls nəzarəti üçün KDT — tətikləyicilərin idarə edilməsi.
3. Kleptomaniya Simptomlarının Qiymətləndirilməsi Şkalası (ing. Kleptomania Symptom Assessment Scale, K-SAS) — Şiddət şkalası.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Grant J.E. — naltrekson sübut bazası.

9. Proqnoz

- Naltrekson və KDT ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Komorbid TDP pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Bütün təkrarlanan oğurluq kleptomaniyadır»

Sübut: əksər oğurluq motivasiya-əsaslı; kleptomaniya nadir.

Mif 2: «Pasient öz iradəsi ilə dayandıra bilər»

Sübut: impuls nəzarəti pozuntusudur — müqavimət göstərmədə uğursuzluq əsas klinik diaqnostik xüsusiyyətdir.

Mif 3: «Hüquqi cəza tək kifayətdir»

Sübut: klinik müdaxilə və komorbidlik müalicəsi residiv riskini azaldır.

Mif 4: «Spesifik müalicə yoxdur»

Sübut: naltrekson sübut bazası (Grant 2009 RKİ); KDT effektivdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C71 Kleptomaniya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Qrant C.E. və b. Kleptomaniyanın müalicəsində opiat antaqonisti naltreksonun ikiqat kor, plasebo nəzarətli tədqiqi. «Bioloji Psixiatriya» (Biol Psychiatry). 2009;65(7):600–606.

XBT-11 **6C72**	**6C72 KOMPULSİV CİNSİ DAVRANIŞ POZUNTUSU** **Compulsive sexual behaviour disorder**
XBT-10 F52.7	Həddindən artıq cinsi istək
DSM-5-TR —	DSM-5-TR-də ekvivalenti yoxdur

1. Tərif və nozologiya

Kompulsiv Cinsi Davranış Pozuntusu (ing. XBT-11: 6C72 Compulsive Sexual Behaviour Disorder) — intensiv, təkrarlanan cinsi impulslara və davranışlara nəzarət etmədə davamlı uğursuzluq modeli; əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma yaradır. XBT-11-də impuls nəzarəti pozuntuları kateqoriyasına daxil edilmişdir.

DSM-5-TR-də ayrıca diaqnoz yoxdur («Hiperseksual pozuntu (ing. hypersexual disorder)» DSM-5-ə daxil edilməmişdir). «cinsi asılılıq (ing. sex addiction)» termini elmi cəmiyyət tərəfindən mübahisəlidir.

2. Tarixçə

- Krafft-Ebing (1886) — «cinsi həyəcanlanmanın artması» (lat. hyperaesthesia sexualis).

- 1980–90-cı illər — «cinsi asılılıq (ing. sexual addiction)» anlayışı (Carnes P.) populyarlaşdı, lakin elmi cəmiyyət tərəfindən mübahisəli qaldı.
- DSM-5 (2013) — «Hiperseksual pozuntu (ing. hypersexual disorder)» daxil edilmədi.
- XBT-11 (2019) — Kompulsiv Cinsi Davranış Pozuntusu (impuls nəzarəti, asılılıq deyil) rəsmi kateqoriya kimi əlavə edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: 1–6% (geniş aralıq, qiymətləndirmə alətlərindən asılı olaraq).
- Cins: kişilərdə yüksək (klinik nümunələrdə 5:1).
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, ŞPP, maddə istifadəsi, OKP, DDHP.

4. Etiologiya və patogenez

- Çoxsaylı amillər — impulsivlik, kompulsivlik, koqnitiv-emosional dizrequlyasiya, travma.
- Maddə istifadəsi pozuntuları və OKP ilə neyrobioloji oxşarlıqlar müəyyən edilmişdir.
- Sosial-mədəni — internet pornoqrafiyasının əlçatanlığı.

5. Klinik təzahürlər

- Cinsi fantaziyalara, impulslara, davranışlara həddindən artıq vaxt sərf etmək.
- Mənfi nəticələrə baxmayaraq davranışın azaldılması cəhdlərinin uğursuzluğu.
- Əzab-əziyyət azaltma və ya emosional qəbul etmə üçün cinsi davranışdan istifadə.
- Cinsi davranışa nəzarətin pozulması ilə əhəmiyyətli funksional pozulma (münasibətlər, iş, sağlamlıq, hüquqi).
- Tipik formalar — kompulsiv masturbasiya, çoxsaylı cinsi tərəfdaşlar, kommersiya cinsi xidmətlərindən istifadə, problemli pornoqrafiyadan istifadə.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (XBT-11)

A. İntensiv cinsi impulslar və davranışları nəzarət etmədə davamlı uğursuzluq paterni.

B. Aşağıdakılardan ≥ 1:

1. Təkrarlanan cinsi fəaliyyət fərdin həyatının digər sahələrinin (sağlamlıq, münasibətlər, məsuliyyət) zəifləməsinə gətirib çıxarır;
2. Pasiyent kontrolü əldə etmək üçün təkrarlanan və əhəmiyyətli cəhdlər göstərmiş, lakin uğursuz olmuşdur;
3. Davranış mənfi nəticələrə baxmayaraq davam edir;
4. Davranış əhəmiyyətli zövq yaratmasa belə davam edir.

C. Müddət ≥ 6 ay.

D. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

E. Yalnız mənəvi-dini mühakimə və qınaqla bağlı əzab-əziyyət meyarı ödəmir; funksional pozulma, yaxud bu mühakimədən asılı olmayan əzab-əziyyət tələb olunur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11: impuls nəzarəti pozuntuları; «cinsi asılılıq» termini istifadə edilmir.
- DSM-5-TR: ayrıca diaqnoz yoxdur; klinik təcrübədə «digər dəqiqləşdirilmiş dağıdıcı davranış, impuls nəzarəti və davranış pozuntuları (ing. other specified disruptive, impulse-control, and conduct disorder)» kateqoriyası daxilində.
- Yalnız mənəvi-dini qınaq əsasında diaqnoz qoyulmamalıdır.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Şkala — Kompulsiv Cinsi Davranış Şkalası (ing. CSBI — Compulsive Sexual Behavior Inventory).
3. Komorbidlik (TDP, narahatlıq, ŞPP, maddə, OKP).
4. Cinsi yolla keçən infeksiyaların (CYKİ; STI) skrininqi
5. Hüquqi və münasibətlərlə bağlı nəticələr.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Manik epizod (hiperseksuallıq)	Affektiv kontekst.
ŞPP (impulsivlik)	Davamlı model bütün sahələrə aiddir.
OKP (cinsi obsessiyalar)	Eqo-distonik obsessiya; ritual.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Parafilik pozuntular (6D3Z)	Spesifik atipik cinsi obyekt.
Yüksək cinsi istək (ing. normal variant)	Funksional pozulma yoxdur.
Təkcə mənəvi-dini qınaq	Klinik diaqnoz əsası deyil.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- CSBI.
- Komorbidlik şkalaları.
- STI skrininq.

8. Müalicə

1. Psixoterapiya birinci xətt müalicəsidir — KDT, ACT (Qəbul və Öhdəlik Terapiyası) və diqqətlilik əsaslı yanaşma. Sübut bazası hələ tam formalaşmamışdır.
2. Naltrekson təsdiqlənməmiş göstərişlə (off-label) — opioid antaqonisti; bəzi tədqiqatlarda mülayim təsir göstərir.
3. SSGİ — komorbid TDP/narahatlıqda.
4. Qrup dəstəyi (ing. S-Anon; SAA — Sex Addicts Anonymous) — köməkçi müalicə üsulu.
5. Münasibətlər və cütlük terapiyası — komorbid kontekstdə.
6. Spesifik farmakoterapiya üçün ABŞ Qida və Dərman Administrasiyasının (FDA) təsdiqi yoxdur.

8.1 Müalicə metodikaları

1. KDT və Qəbul-Öhdəlik Terapiyası (ACT) — Tətikləyicilərin idarəsi, dəyər-əsaslı davranış.
2. Naltrekson off-label — İstək şiddətinin azaldılması (craving)
3. Kompulsiv Cinsi Davranış Şkalası (ing. CSBI — Compulsive Sexual Behavior Inventory) — Şiddət şkalası.
4. Özünəyardım (SAA, SLAA) — 12 addımlı proqram əsasında; sübut bazası məhdud.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ÜST — XBT-11 rəsmi kateqoriya kimi təsdiqləyib.
- APA — DSM-5-TR-də ayrıca diaqnoz yox; mübahisəli sahə.

9. Proqnoz

- KDT və ACT ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Komorbidlik müalicəsi vacib.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Cinsi asılılıq maddə asılılığı kimi diaqnozdur»

Sübut: XBT-11 — impuls nəzarəti pozuntusu; «asılılıq» anlayışı mübahisəlidir və DSM-5-də qəbul edilməmişdir.

Mif 2: «Yüksək cinsi maraq cinsi asılılığın (ing. sex addiction) əlamətidir»

Sübut: klinik diaqnoz funksional pozulma və nəzarətin itirilməsini tələb edir; sadəcə yüksək cinsi fəaliyyət xəstəlik deyil.

Mif 3: «Mənəvi-dini normanın pozulması diaqnoz üçün əsasdır»

Sübut: XBT-11 — mənəvi-dini sıxıntı kifayət deyil; funksional pozulma və ya nəzərəçarpan əzab-əziyyət tələb olunur.

Mif 4: «Pornoqrafiyadan istifadə həmişə xəstəlikdir»

Sübut: normal istifadə və kompulsiv istifadə fərqlidir; nəzarətin pozulması və funksional pozulma diaqnostik əhəmiyyət daşıyır.

Mif 5: «Kimyəvi kastrasiya (testosteron supressiyası) standart müalicədir»

Sübut: bu yanaşma yalnız ağır parafilik pozuntularda pedofiliya ilə əlaqəli yüksək risk WFSBP göstərişinə görə; ümumi kompulsiv cinsi davranış üçün tövsiyə edilmir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C72 Kompulsiv cinsi davranış pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Kraus S.V. və b. XBT-11-də kompulsiv cinsi davranış pozuntusu. «Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry). 2018;17(1):109–110.
4. Qrubbs C.B., Hoqland K.C., Li B.N. və b. Cinsi asılılıq — 25 il sonra. «Klinik Psixologiya İcmalı» (Clin Psychol Rev). 2020;82:101925.

XBT-11 **6C73**	**6C73 EPİZODİK EKSPLOSİV POZUNTU (EEP)** **Intermittent explosive disorder**
XBT-10 F63.8	Digər adət və impuls pozuntuları
DSM-5-TR F63.81	Epizodik eksploziv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Epizodik eksploziv pozuntu (EEP; XBT-11: 6C73 — epizodik eksploziv pozuntu; DSM-5-TR: F63.81) — təkrarlanan, nəzarətdən çıxan şifahi və ya fiziki aqressiya püskürmələri; tətikləyici provokasiya ilə uyğunsuz dərəcədə intensiv. Aktdan sonra peşmanlıq və ya utanc hissi yaranır.

2. Tarixçə

- DSM-III (1980) — EEP rəsmi diaqnoz.
- DSM-5 (2013) — meyarlar dəqiqləşdirilmişdir.
- XBT-11 (2019) — impuls nəzarəti pozuntuları daxilində.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: 4–7% (Kessler R.C. və b. Arch Gen Psychiatry 2006).
- Cins: qadınlarla müqayisədə kişilərdə daha yüksəkdir.
- Başlanğıc: orta yeniyetməlik.
- Komorbidlik: TDP təxminən 70%, narahatlıq, maddə istifadəsi, ŞPP, ASP.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 40%-dir.
- Serotonin dizrequlyasiyası — SSGİ-nin təsiri.
- Travma və zorakılıq tarixçəsi.
- Kortikal-amigdala tənzimlənməsinin pozulması.

5. Klinik təzahürlər

- Təkrarlanan aqressiya partlayışları — verbal (qışqırma, təhdid) və ya fiziki (əmlakın zədələnməsi, başqalarına zərər).
- Aqressiya püskürməsi nəzarətdən çıxır — pasient özünü saxlaya bilmir.
- Tətikləyici minimal və ya cüzi olur.
- Aktdan sonra peşmanlıq, utanc və günah hissi yaranır.
- Münasibət, iş, hüquqi nəticələr.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Aşağıdakılardan biri:

1. Şifahi və ya fiziki aqressiya püskürmələri — əmlaka ziyan vurmadan və ya başqalarına xəsarət yetirmədən, həftədə ≥ 2 dəfə, ≥ 3 ay;
2. 12 ay ərzində üç və ya daha çox dağıdıcı və ya zədələyici püskürmə.

B. Aqressiyanın şiddəti tətikləyiciyə uyğunsuz dərəcədə yüksəkdir.

«İmpulsiv (planlaşdırılmamış) və konkret məqsəd güdməyən»

D. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

E. Xronoloji yaş ≥ 6 (və ya ekvivalent inkişaf səviyyəsi).

F. Başqa psixi pozuntu (manik, ASP, ŞPP, davranış pozuntusu) ilə daha yaxşı izah olunmur; maddə təsiri istisnası.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — DSM-5-TR-də A1 (dağıdıcı olmayan) və A2 (dağıdıcı) meyarları ayrı-ayrı təqdim edilmişdir.
- XBT-11 — nə tezlik, nə də yaş meyarı var: DSM-5-TR A1/A2 bölgüsü, həftədə iki dəfə üç ay və ya 12 ayda üç dağıdıcı epizod, həmçinin ≥ 6 yaş tələb edir; XBT-11-də bu meyarların heç biri yoxdur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və ailə məlumatları.
2. Şkalalar — Açıq Aqressiya Şkalası (ing. Overt Aggression Scale, OAS) və Buss-Perri Aqressiya Anketi (ing. Buss-Perry Aggression Questionnaire, BPAQ).

3. Komorbidlik və tibbi səbəblərin istisnası (frontal lob zədəsi, epilepsiya, hipoglikemiya).
4. Toksikoloji.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
ASP (Antisosial)	Planlaşdırılmış aqressiya, peşmanlıq yox.
ŞPP	Emosional dəyişkənlik və münasibətlər əsas.
Manik epizod	Affektiv epizod kontekstində.
Davranış pozuntusu (6C91)	Çoxsaylı antisosial davranış.
MİP (6C90)	Davamlı opozisional, aqressiya komponenti var, lakin partlayış əsas deyil.
Frontal lob patologiyası	Neyroloji.
Maddə induksiyalı aqressiya	Toksikoloji.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- OAS, BPAQ.
- Tibbi və neyroloji.
- Toksikoloji.
- Komorbidlik şkalaları.

8. Müalicə

1. Fluoksetin (SSGİ) — Coccaro E.F. və b. J Clin Psychiatry 2009 RKİ — EEP-də ən sübutlu farmakoterapiya; 20–60 mq/gün.
2. KDT — qəzəb idarəsi, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, davranış aktivasiyası, relaksasiya. McCloskey M.S. və b. J Consult Clin Psychol 2008.
3. Əhval stabilləşdiriciləri — valproat, lityum (off-label refrakter halda).
4. Komorbid pozuntuların müalicəsi.
5. Hüquqi koordinasiya zəruri olduqda.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Fluoksetin — SSGİ; EEP-də Coccaro RKİ sübut bazası.
2. Qəzəb idarəsi üçün KDT — Tətikləyici identifikasiyası, koqnitiv yenidən strukturlaşdırma, fasilə vermə (time-out), relaksasiya, problemin həlli.
3. Açıq Aqressiya Şkalası (ing. Overt Aggression Scale, OAS) — aqressiya şiddəti şkalası.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Coccaro J Clin Psychiatry 2009 — fluoksetin sübutlu.
- Makkloski M.S. və b., 2008 — KDT-nin effektivliyi.

9. Proqnoz

- Fluoksetin və KDT ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.
- Komorbid ASP, maddə istifadəsi pis proqnoz.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «EEP — adi „tutum çıxma“dır»

Sübut: klinik diaqnoz tezlik və funksional pozulma əsasında qoyulur.

Mif 2: «Pasient öz iradəsi ilə dayandıra bilər»

Sübut: impuls nəzarəti pozuntusudur — nəzarətin itirilməsi klinik xüsusiyyətdir; sübutlu müalicə (fluoksetin, KDT) tələb olunur.

Mif 3: «Benzodiazepin aqressiyanı azaldır»

Sübut: benzodiazepin paradoksal disinhibisiya yarada bilər; EEP-də əks-göstəriş və ya ehtiyatla.

Mif 4: «Yalnız hüquqi cəza effektivdir»

Sübut: yalnız hüquqi cəza təsirsizdir; klinik müalicə tələb olunur.

Mif 5: «Antipsixotiklər birinci xətt müalicəsidir»

Sübut: SSGİ birinci xətt müalicəsidir; antipsixotiklər davamlı hallarda tətbiq olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C73 Epizodik partlayıcı pozuntu. 2024.

2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Kokkaro E.F. və b. Epizodik partlayıcı pozuntu olan xəstələrdə fluoksetinin ikiqat kor, randomizə edilmiş, plasebo nəzarətli sınağı. «Klinik Psixiatriya Jurnalı» (J Clin Psychiatry). 2009;70(5):653–662.
4. Makkloski M.S. və b. Epizodik partlayıcı pozuntu üçün koqnitiv-davranış terapiyası. «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 2008;76(5):876–886.
5. Kessler R.C. və b. DSM-IV epizodik partlayıcı pozuntusunun yayılması və əlaqəli amilləri. «Ümumi Psixiatriya Arxivləri» (Arch Gen Psychiatry). 2006;63(6):669–678.

6C90–6C9Z DAĞIDICI DAVRANIŞ VƏ YA DİSSOSİAL POZUNTULAR

Dağıdıcı davranış və ya dissosial pozuntular (disruptive behaviour or dissocial disorders)

XBT-11 **6C90**	**6C90 MÜXALİF-İNADKAR POZUNTU (MİP)** **Oppositional defiant disorder**
XBT-10 F91.3	Müxalif-inadkar pozuntu
DSM-5-TR F91.3	Müxalif-inadkar pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Müxalif-inadkar pozuntu (ing. ODD; XBT-11: 6C90 Oppositional Defiant Disorder; DSM-5-TR: F91.3) — qəzəbli/irritabel əhval, dava-dalaşçı/inadkar davranış və ya intiqamlı davranış nümunəsi. Davranış pozuntusundan (6C91) fərqli olaraq, başqalarının əsas hüquqlarına müdaxilə yoxdur.

2. Tarixçə

- DSM-III (1980) — rəsmi diaqnoz.
- DSM-5 (2013) — emosional komponent (qəzəbli/irritabəl) ayrıca vurğulanır.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: 1–11% (orta hesabla 3,3%) məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlarda (DSM-5-TR).
- Cins: prepubertat oğlanlarda yüksək; postpubertat fərq azalır.
- Komorbidlik: DDHP təxminən 40–60%, TDP, narahatlıq, CD-yə keçid 30%-də (uşaqlıq tipi ağır halda).

4. Etiologiya və patogenez

- İrsi payı 50% təşkil edir.
- Mühit — sərt valideyn təcrübəsi, ailə disfunksiyası.
- Neyrobioloji amillərə affektiv tənzimləmə və frontal-amigdala dövrəsinin fəaliyyəti aiddir.
- Temperament amilləri (irritabellik).

5. Klinik təzahürlər

8 simptom 3 kateqoriyada (6 ay ərzində ≥ 4 simptom)

- Qəzəbli/irritabəl əhval: tez-tez qəzəblənmə; tez-tez əsəbiləşmə; tez-tez qəzəbli və narazı olma.
- Dava-dalaşçı/inadkar davranış: böyüklərlə mübahisə; qaydalara tabe olmama; başqalarını qəsdən narahat etmə; başqalarını günahlandırma.
- İntiqamlı davranış: son 6 ayda ən azı 2 dəfə.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR — 8-dən ≥ 4 simptom 6 ay; ən azı bir kontekstdə (ev, məktəb, həmyaşıdlar arasında); ən azı bir başqa kontekstdə fərqli şəxslə.

Yaş kvalifikatoru: 5 yaşa qədər simptomlar əksər günlərdə 6 ay; 5 yaş və yuxarı — həftədə ən azı 1 dəfə, 6 ay ərzində.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — şiddət (yüngül, orta, ağır) kontekst sayına görə.
- NICE CG158 — uşaqlarda antisosial davranışın idarə edilməsi üzrə rəhbərlik.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə valideyn və müəllimlə aparılır.
2. Uşaq Davranış Yoxlama Siyahısı (CBCL), Müəllim Hesabat Forması (TRF), Eyberg Uşaq Davranış Sorğusu (ECBI)
3. Komorbid DDHP üçün skrininq aparılır.
4. Pozucu əhval tənzimləmə pozuntusu (DMDD — ing. Disruptive Mood Dysregulation Disorder) və depressiv pozuntu fərqi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
CD (6C91)	Ağır hüquq pozulması.
DDHP	Diqqət və impulsivlik pozuntusu; komorbid hallarda tez-tez rast gəlinir.
DMDD (DSM-5-TR)	Davamlı irritabellik + ağır qəzəb partlayışları, ≥ 12 ay (ardıcıl 3 aydan uzun simptomsuz dövr olmadan); MİP meyarları da ödənildikdə yalnız DMDD diaqnozu qoyulur.
Təşviş pozuntusu	Narahatlıq komponenti dominant.
İntellektual əlillik	Koqnitiv çatışmazlıq kontekstdə davranış pozulması.
Yaşa uyğun «uşağın müqaviməti»	Funksional pozulma yoxdur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- ECBI, CBCL.
- Komorbid DDHP, narahatlıq, TDP.

8. Müalicə

1. Valideyn təlimi birinci sıra:
    - PCIT — 2–7 yaş;
    - «İnanılmaz illər» (ing. Incredible Years) proqramı — 3–8 yaş;
    - Valideyn idarəetmə təlimi (ing. Parent Management Training) — Barkli — 6+ yaş;
    - Triple P.
2. Komorbid DDHP olduqda stimulyant təyin edilir.
3. SSGİ — komorbid narahatlıq/depressiya.
4. Məktəb əsaslı müdaxilə.
5. Uşağa qarşı amansız rəftar və ya ailədaxili zorakılıq şübhəsi — uşaq müdafiəsi və sosial xidmətlərlə koordinasiya.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Valideyn-Uşaq Qarşılıqlı Təsir Terapiyası (PCIT) real vaxtda terapevtin koçluğu.
2. «İnanılmaz illər» (ing. Incredible Years) proqramı — qrup formatı.
3. Pozitiv Valideynlik Proqramı (ing. Triple P — Positive Parenting Program) — 5 pilləli sistem.
4. Valideyn İdarəetmə Təlimi (ing. Parent Management Training) — Barkli (Barkley) — Davranış prinsiplərinə əsaslanan təlim.
5. Eyberg Uşaq Davranış Sorğusu (ECBI — Eyberg Child Behavior Inventory) — Valideyn tərəfindən doldurulan davranış şkalası.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG158.
- AACAP — valideyn təlimi.

9. Proqnoz

- Erkən valideyn təlimi ilə pasiyentlərin əksəriyyəti yaxşılaşır.
- Komorbid DDHP, ağır variantı — CD/ASP riski.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «MİP adi „inadkar uşaq“ davranışıdır»

Sübut: klinik diaqnoz funksional pozulma və tezlik əsasında; normal yaş varyantından fərqlidir.

Mif 2: «Sərt intizam MİP-ni düzəldər»

Sübut: sərt cəza simptomları gücləndirir; effektiv yanaşma pozitiv valideyn təlimidir.

Mif 3: «Antipsixotik birinci sıra»

Sübut: valideyn təlimi birinci sıra; antipsixotiklər yalnız refrakter hallarda, nadir hallarda tətbiq edilir.

Mif 4: «MİP həmişə CD-yə çevrilir»

Sübut: 30%-də DP-yə keçid; uşaqlıq tipi və komorbidliklə risk yüksək; əksəriyyət CD-yə çevrilmir.

Mif 5: «Yalnız uşaq müalicə olunmalıdır, ailə yox»

Sübut: valideyn təlimi mərkəzi komponentdir; uşaq üçün təkbaşına psixoterapiya az effektivdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C90 Müxalifətçi-çağırış pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik təlimat CG158. 2017.
4. Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyası (AACAP). Təcrübə Parametri (Ştayner, 2007).
5. Eyberg S.M. və b. Pozucu davranışı olan uşaqlar və yeniyetmələr üçün sübuta əsaslanan psixososial müalicələr. «Klinik Uşaq və Yeniyetmə Psixologiyası Jurnalı» (J Clin Child Adolesc Psychol). 2008;37(1):215–237.
6. Sanders M.R. Üçqat P — Müsbət Valideynlik Proqramının hazırlanması, qiymətləndirilməsi və çoxmillətli yayılması. «Klinik Psixologiyanın İllik İcmalı» (Annu Rev Clin Psychol). 2012;8:345–379.

XBT-11 **6C91**	**6C91 DAVRANIŞ-DİSSOSİAL POZUNTU** **Conduct-dissocial disorder**
XBT-10 F91	Davranış pozuntuları
DSM-5-TR F91.1	Davranış pozuntusu, uşaqlıq dövründə başlanan tip

1. Tərif və nozologiya

Dağıdıcı davranış və dissosial pozuntu (ing. XBT-11: 6C91 Conduct-Dissocial Disorder; DSM-5-TR: F91.1 Conduct Disorder) — başqalarının hüquqlarına və yaşa uyğun sosial normalara davamlı və təkrarlanan müdaxilə paterni. Tipik uşaqlıq/yeniyetməlikdə başlayır; yetkinlikdə antisosial şəxsiyyət pozuntusuna keçə bilər.

2. Tarixçə

- DSM-III (1980) — rəsmi diaqnoz kimi daxil edilmişdir.
- DSM-5 (2013) — «məhdud prososial emosiyalar (ing. limited prosocial emotions)» kvalifikatoru (psixopati xüsusiyyətlərinin uşaqlıq markeri).
- NICE CG158 (2017) — Milli Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu: uşaq və yeniyetmələrdə antisosial davranış üzrə təlimat.

3. Epidemiologiya

- 12 aylıq yayılma: 2–10%, median 4%, median 4%; oğlanlarda qızlardan daha yüksəkdir (DSM-5-TR).
- Cins: kişilərdə 3 dəfə yüksəkdir.
- Başlanğıc — uşaqlıq (10 yaşa qədər, pis proqnoz) və ya yeniyetməlik (10 yaşdan yuxarı, daha yaxşı proqnoz).
- Komorbidlik: DDHP 50%, MİP, TDP, narahatlıq, maddə istifadəsi, öyrənmə pozuntuları.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 40–60%-dir.
- Neyrobioloji — amigdalanın və prefrontal korteksin dizrequlyasiyası, simpatik oyanmanın aşağı səviyyəsi (sympathetic arousal)
- Mühit — uşaqlıq travması, sərt valideynlik tərbiyəsi, ailə disfunksiyası, həmyaşıd mühitinin təsiri.
- Prenatal dövrdə — tütün və alkohol təsiri.

5. Klinik təzahürlər

DSM-5-TR-in 15 simptomu 4 kateqoriyada qruplaşdırılmışdır (12 ay ərzində ≥ 3 simptom)

- Aqressiya — insanlara/heyvanlara: təhdid, hücum, silahdan istifadə, fiziki zorakılıq, cinsi zorakılıq.
- Əmlakın zədələnməsi: qəsdən yanğın salma, başqa əşyaların zədələnməsi.
- Aldatma və oğurluq: evə qanunsuz daxil olma, yalan danışma, oğurluq.
- Qaydaların ciddi pozulması: gec gəlmə, evdən qaçma, məktəbə getməmə (dərsdən yayınma; truancy).

«Məhdud prososial emosiyalar (ing. limited prosocial emotions)» kvalifikatoru (psixopatik xüsusiyyətlər)

- Empati və ya peşmanlıq yoxluğu;
- Nəticələrə biganəlik;
- Affektiv laqeydlik (ing. callous lack of empathy);
- Səthi affekt.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

DSM-5-TR meyarları (15-dən ≥ 3 simptom 12 ay; ən azı 1 simptom son 6 ay). Şiddət: yüngül, orta, ağır.

Başlanğıc: uşaqlıq tipi (≥ 1 simptom 10 yaşa qədər), yeniyetməlik tipi.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — «məhdud prososial emosiyalar (ing. limited prosocial emotions)» kvalifikatoru.
- XBT-11 — «Dağıdıcı davranış və dissosial pozuntu (ing. conduct-dissocial disorder)»; uşaq, yeniyetmə və yetkin formalarına görə.
- NICE CG158 — diaqnoz və müdaxilə uşaq və yeniyetmələrə aiddir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə, həmçinin valideyn və müəllim məlumatları.
2. Strukturlaşdırılmış müsahibə (K-SADS).
3. Uşaq Davranışı Yoxlama Siyahısı (CBCL — Child Behavior Checklist) və Müəllim Məlumat Forması (TRF — Teacher Report Form).
4. ICU (ing. Inventory of Callous-Unemotional Traits) — psixopatik xüsusiyyətlər üçün.
5. Komorbidlik (DDHP, TDP, maddə, öyrənmə).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
MİP (6C90)	Yüngül, ciddi hüquq pozulması yox.
DDHP (6A05)	İmpulsivlik və diqqət; komorbid sıx.

Vəziyyət	Fərqləndirici
EEP (6C73)	Patlayış əsas; davamlı antisosial model yox.
Manik epizod	Affektiv kontekst.
RPP/DİRP (6B44/6B45)	Bağlanma pozuntusu uşaqlıqdan.
Maddə induksiyalı	Toksikoloji.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- CBCL, TRF, ICU.
- Komorbidliyin skrininqi.
- İntellektual və akademik qiymətləndirmə.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG158, AACAP)

1. Valideyn təlimi (ing. parent training programs) 3–11 yaşlı uşaqlar üçün birinci xətt müdaxiləsidir:
    - «İnanılmaz İllər» (Incredible Years) proqramı (Vebster-Stratton);
    - PCIT (Valideyn-Uşaq Qarşılıqlı Təsir Terapiyası; parent-child interaction therapy);
    - Triple P.
2. Yeniyetmələr üçün:
    - Çoxsistemli Terapiya (ing. multisystemic therapy; Henggeler S.V., MST) — ailə, həmyaşıdlar, məktəb və icmanı əhatə edir;
    - FFT — Funksional Ailə Terapiyası (ing. functional family therapy);
    - MTFC — Çoxölçülü Müalicəvi Qəyyumluq (ing. multidimensional treatment foster care).
3. Komorbid DDHP-də stimulyantlar tətbiq olunur (aqressiyanı da azaldır).
4. Antipsixotik (risperidon) — ağır aqressiyada off-label, ehtiyatla; FDA təsdiqi yox (uşaq aqressiyası üçün spesifik).
5. «Scared Straight» (qorxutma proqramı) və oxşar proqramlar əks-göstərişdir — Cochrane (Petrosino A. 2013) — bu proqramlar antisosial davranışı artırır.

6. «Boot camp» (hərbi düşərgə) tipli «tough love» proqramları — sübut bazası yoxdur və zərərlidir.

8.2 Müalicə metodikaları

1. «Incredible Years» proqramı — Vebster-Stratton (Webster-Stratton) — 3–8 yaşlı uşaqların valideynləri üçün qrup proqramı; 14–22 seans (NICE CG158 üzrə valideyn təlimi proqramları 3–11 yaş aralığını əhatə edir).
2. Valideyn-Uşaq Qarşılıqlı Təsir Terapiyası (ing. parent-child interaction therapy, PCIT) — 4–7 yaş; CDI + PDI.
3. Çoxsistemli Terapiya (ing. Multisystemic Therapy, MST) — Yeniyetmələr üçün ev şəraitində aparılan multisistem müdaxiləsi; ağır davranış pozuntusu üçün güclü sübut bazasına malikdir.
4. Funksional Ailə Terapiyası (ing. Functional Family Therapy, FFT) — ailə əsaslı, 8–30 seans.
5. Çoxölçülü Müalicə Himayə Qayğısı (ÇMMHQ; ing. MTFC — Multidimensional Treatment Foster Care) — Strukturlaşdırılmış himayədar ailə proqramı; ağır hallarda tətbiq edilir.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG158 (2017).
- AACAP Practice Parameter (Steiner H. 2007).
- Cochrane (Petrosino 2013) — «Qorxuya əsaslanan proqramlar» (ing. Scared Straight) əks göstərişdir.

9. Proqnoz

- Uşaqlıq tipi və psixopatik xüsusiyyətlərlə — yetkinlikdə ASP təxminən 40–50% riski.
- Yeniyetməlik tipi yaxşı proqnoz verir.
- Erkən valideyn təlimi və multisistem müdaxiləsi nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Sərt cəza/intizam ən effektiv müdaxilədir»

Sübut: sərt cəza antisosial davranışı gücləndirir; pozitiv valideyn təlimi sübutludur.

Mif 2: «Qorxuya əsaslanan (ing. Scared Straight) proqramlar gəncləri „düzəldir“»

Sübut: Petrosino A. Cochrane 2013 — Scared Straight antisosial davranışı artırır (OR 1,68; 95% Eİ 1,20–2,36); əks-göstərişdir; mediada bəzən «təsirli» kimi təqdim edilir, lakin meta-analizin nəticəsi mənfidir.

Mif 3: «Davranış pozuntusu mütləq ASP-yə çevrilir»

Sübut: təxminən 50% halların yeniyetmələk tipi remissiya edir; uşaqlıq tipi və psixopatik xüsusiyyətlərlə pis proqnoz.

Mif 4: «Stimulyant aqressiyanı artırır»

Sübut: komorbid DDHP olduqda stimulyantlar aqressiyanı azaldır; istifadə davranışın və yan təsirlərin monitorinqi ilə aparılır.

Mif 5: «Hərbi düşərgə (ing. boot camp) və ya hərbi mühit ağır davranış pozuntusunu (DP) sağaldır»

Sübut: sübut yoxdur; bəzi tədqiqatlarda əksinə, vəziyyətin pisləşdiyi göstərilmişdir.

Mif 6: «Antipsixotik standart birinci sıra»

Sübut: valideyn təlimi və psixososial yanaşmalar birinci sıra; risperidon ağır refrakter hallarda qeyri-rəsmi göstərişlə (ing. off-label) tətbiq edilir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6C91 Davranış-dissosial pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik təlimat CG158. Uşaqlar və yeniyetmələrdə antisosial davranış və davranış pozuntuları: tanınması və idarə edilməsi. 2017.
4. Ştayner H., Remsinq L. Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının (AACAP) davranış pozuntusunun qiymətləndirilməsi və müalicəsi üzrə Təcrübə Parametri. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyası Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry). 2007;46(1):126–141.
5. Petrosino A. və b. «Qorxudulmuş düz yol» (Scared Straight) və yeniyetmə cinayətkarlığının qarşısının alınması üzrə digər yeniyetmə maarifləndirmə

proqramları. «Cochrane Sistemli İcmallar Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2013;(4):CD002796.

6. Henggeler S.V. Multisistemik terapiya. Qilford Nəşriyyatı; 1998.
7. Sanders M.R. Üçqat P — Müsbət Valideynlik Proqramının hazırlanması, qiymətləndirilməsi və çoxmillətli yayılması. «Klinik Psixologiyanın İllik İcmalı» (Annu Rev Clin Psychol). 2012;8:345–379.

6D10–6D1Z ŞƏXSİYYƏT POZUNTULARI

Şəxsiyyət pozuntuları və əlaqəli xüsusiyyətlər

XBT-11 **6D10**	**6D10 ŞƏXSİYYƏT POZUNTUSU** **Personality disorder**
XBT-10 F60.9	Dəqiqləşdirilməmiş şəxsiyyət pozuntusu
DSM-5-TR F60.9	Dəqiqləşdirilməmiş şəxsiyyət pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Şəxsiyyət Pozuntusu (ing. XBT-11: 6D10 Personality Disorder; DSM-5-TR: F60.9; 10 kateqoriya) — şəxsi və sosial fəaliyyətdə özünə və başqalarına dair fikir, hiss və davranışlarda təzahür edən davamlı və geniş yayılmış model. XBT-11 fundamental olaraq vahid kateqoriya + şiddət dərəcələri + xüsusiyyət domenləri modelinə keçmişdir; klassik 10 ayrı şəxsiyyət pozuntusu (paranoid, şizoid, sərhəd, antisosial və s.) kateqoriya əsaslı diaqnoz kimi ləğv edilmişdir.

2. Tarixçə

- DSM-III (1980) — kateqorial 11 şəxsiyyət pozuntusu (Klaster A, B, C).
- DSM-IV (1994), DSM-5 (2013), DSM-5-TR (2022) — eyni kateqoriya modeli saxlanılır; lakin DSM-5-in III bölməsindəki tədqiqat kateqoriyasında alternativ «dimensional» model.
- XBT-11 (2019) — radikal dəyişiklik: kateqoriya əsaslı 10 pozuntu ləğv edilmişdir, vahid Şəxsiyyət Pozuntusu (ing. yüngül, orta, ağır + Personality Difficulty) + 5 xüsusiyyət sahə qiymətləndirməsi.

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: təxminən 9% (Lenzenweger M.F. və b. Biol Psychiatry 2007); ŞPP təxminən 1,4%, ASP təxminən 1%, schizoid 3%.

- Cins: ŞPP qadınlarda klinik əhali (populyasiya) qruplarında; ASP kişilərdə yüksək.
- Başlanğıc yeniyetməlik və erkən yetkinlik dövrünə təsadüf edir.
- Mortalite: ŞPP-də intihar 8–10% ömürlük; ASP-də zorakı ölüm.
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, maddə istifadəsi, yemə pozuntuları.

4. Etiologiya və patogenez

- İrsilik 40–60%.
- Erkən travma, uşaqlıq istismarı (xüsusilə ŞPP).
- Disorganized bağlanma.
- Neyrobioloji — frontal-limbik tənzimləmə, serotoninergik disregulyasiya.

5. Klinik təzahürlər

5.1 XBT-11 5 xüsusiyyət sahə

- Mənfi affektivlik — narahatlıq, depressiya, emosional labillik.
- Təcrid (ing. Detachment) — sosial və emosional uzaqlaşma.
- Dissosiallıq — empati çatışmazlığı, eqosentrizm.
- Dezinhibisiya — impulsivlik, məsuliyyətsizlik.
- Anankastiya — perfeksionizm, nəzarət, sərt qaydalar.

«Sərhəd nümunəsi» (6D11.5) — XBT-11-də ayrıca kvalifikator (ŞPP-yə müvafiq, kateqorial 10 ayrı diaqnoz əvəzinə).

5.2 DSM-5-TR üzrə 10 kateqoriya pozuntu (qısa icmal)

- Klaster A (qəribə/eksentrik): Paranoid, Şizoid, Şizotipal.
- Cluster B (dramatik/erratik): Antisocial (ASP), Borderline (ŞPP), Histrionic, Narcissistic.
- Klaster C (narahat/qorxulu): Çəkingən, Asılı, Obsessiv-kompulsiv (OKPP).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (XBT-11)

A. Davamlı və yayğın şəxsiyyət disfunksiyası — özünə dair (identifikasiya, özünə qiymət, özünüidarə) və ya şəxslərarası (münasibətlər, empatiya, intimasi, məsuliyyət) funksiyada.

B. Müddət — uzunmüddətli (illər).

C. İnkişaf yaşına, mədəni normalara və ailə vəziyyətinə uyğun olmayan davranış.

D. Şiddət: Şəxsiyyət çətinliyi (subklinik), yüngül ŞP, orta ŞP, ağır ŞP.

E. Xüsusiyyət sahə kvalifikatorları (yuxarıda).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11: kateqorial sistemə radikal dəyişiklik; klinik təcrübədə təlim tələb edir.
- DSM-5-TR: 10 kateqorial diaqnoz saxlanılır; III bölmədə alternativ model.
- NICE CG78 (ŞPP), CG77 (ASP): ŞPP və ASP üçün ayrı klinik göstərişlər.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + uzun tarixçə.
2. SCID-5-PD (DSM kateqorial) və ya XBT-11 üzrə şəxsiyyət pozuntusunun qiymətləndirilməsi.
3. Şəxsiyyət şkalaları — PID-5 (DSM-5-in ölçülü modeli), MMPI-2-RF.
4. Komorbidlik (TDP, maddə, travma).
5. Suicid və zorakılıq riski.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Affektiv epizod kontekstində dəyişiklik	Epizodik gediş; şəxsiyyət davamlı.
Maddə induksiyalı	Maddə tarixçəsi.
PTSP / kompleks PTSP	Travma kontekstində; klinik üst-üstə düşmə ŞPP-də.
Bipolyar	Affektiv epizodlar.
Tibbi vəziyyət (frontal lob, demensiya)	Neyroloji.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- SCID-5-PD, PID-5.
- MMPI-2-RF, MCMI-IV.
- Komorbidlik və intihar.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG78 (ŞPP), CG77 (ASP); APA 2024 (ŞPP, 2-ci nəşr))

1. Şəxsiyyət pozuntularında psixoterapiya birinci sıra müalicə üsulu hesab edilir.
2. ŞPP üçün sübutlu yanaşmalar (5):
    - DBT (ing. Dialectical Behavior Therapy, Linehan M.) — emosional tənzimləmə, əzab-əziyyət dözümlülüyü, sosial bacarıqlar, şüurlu diqqət (ing. mindfulness); standart 12 ay;
    - Mentalizasiya Əsaslı Terapiya (MBT; ing. Mentalization-Based Treatment) — Beytmən (Bateman A.), Fonaqi (Fonagy P.);
    - Sxem terapiyası (ing. Schema Therapy) — Yanq (Young J.);
    - Transferens-Fokuslu Psixoterapiya (TFP; ing. Transference-Focused Psychotherapy) — Kernberq (Kernberg O.);
    - Emosional Proqnozlaşdırma və Problemlərin Həlli üçün Sistem Təlimi (ing. STEPPS).
3. ASP üçün — terapevtik məhdudiyyət; struktur, motivasiyalı pasiyentdə KDT.
4. Farmakoterapiya — şəxsiyyət pozuntusunun özü üçün spesifik təsdiqlənmiş müalicə yoxdur; komorbid simptomlar (impulsivlik, depressiya, narahatlıq, psixozabənzər) üçün — SSGİ, əhval stabilləşdiriciləri, atipik antipsixotik aşağı dozada.
5. Böhran idarəsi — DDT bacarıqları (ing. DBT skills), qısamüddətli xəstəxanaya yerləşdirmə.
6. Uzunmüddətli müalicə (illər).

8.2 Müalicə metodikaları

1. Dialektik Davranış Terapiyası (ing. Dialectical Behavior Therapy, DBT) — Linehan (Linehan M.) — 4 modul (şüurlu diqqət, əzab-əziyyət dözümlülüyü, emosional tənzimləmə, sosial bacarıqlar); fərdi + qrup + telefonla koçluq və terapevt konsultasiyası. 12 ay standart. Sübut: Linehan M.M. JAMA Psychiatry 2015.
2. Mentalizasiya-Əsaslı Terapiya (MBT; ing. Mentalization-Based Treatment) — Beytmən (Bateman A.), Fonaqi (Fonagy P.) — Mentalizasiya — özünün və başqalarının zehni vəziyyətlərinin tanınması; psixodinamik kökə əsaslanan. Bateman A. Am J Psychiatry 2009.

3. Sxem Terapiyası (ing. Schema Therapy) — Yanq (Young J.) — erkən maladaptiv sxemlərin yenidən qurulması; uzunmüddətli psixoterapiya.
4. Transferans-Fokuslu Psixoterapiya (TFP — Transference-Focused Psychotherapy) — Kernberq (Kernberg O.) — Transferensiya kontekstində primitiv müdafiə mexanizmlərinin emalı (termin bütün mətndə vahid işlədilməlidir).
5. STEPPS — 20 həftəlik qrup; ŞPP pasiyentinin sosial sisteminin də iştirakı.
6. Alət 6.3/7-ci bölməyə keçirilməlidir: «Şəxsiyyət pozuntuları üçün strukturlaşdırılmış klinik müsahibə (SCID-5-PD) — DSM-5 üzrə kateqoriya diaqnozu».

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG78 (ŞPP, 2009) — DBT, MBT və oxşar strukturlaşdırılmış yanaşmalar; farmakoterapiya rutin tövsiyə edilmir ŞPP-nin özü üçün.
- NICE CG77 (ASP, 2009).
- APA Practice Guideline for the Treatment of Patients With Borderline Personality Disorder, 2-ci nəşr (2024) — 2001-ci il nəşrini əvəz etdi.

9. Proqnoz

- ŞPP — 10 il izləmədə 50%+ remissiya (Zanarini M.C. icmalları).
- ASP — ən pis proqnoz; lakin yaşla aqressiya azalır.
- Müalicə proqnozu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Şəxsiyyət pozuntuları müalicə olunmur»

Sübut: DBT, MBT, sxem terapiyası, TFP — sübutlu yanaşmalar; pasiyentlərin əksəriyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşır; bədbin proqnostik mövqe köhnəlmişdir.

Mif 2: «ŞPP pasiyentlər manipulyativdir, sərt sərhəd tələb edir»

Sübut: «manipulyativ» termini damğalayıcı və yanlışdır; ŞPP davranışları emosional tənzimləmə pozuntusundan qaynaqlanır; DBT etibarlılıq yoxlanışı (validasiya) + struktur balansını tövsiyə edir.

Mif 3: «Farmakoterapiya ŞPP-ni sağaldır»

Sübut: NICE CG78 — farmakoterapiya ŞPP-nin özü üçün rutin tövsiyə edilmir; psixoterapiya birinci sıra.

Mif 4: «ASP müalicə oluna bilməz»

Sübut: ağır ASP-də müdaxilə məhduddur, lakin motivasiyalı pasiyentdə struktur müalicə yaxşılaşma verə bilər; nihilist mövqe əks göstərişdir.

Mif 5: «Yaşla şəxsiyyət pozuntusu sabitləşir, müalicə tələb etmir»

Sübut: uzunmüddətli izləmə — ŞPP remissiya nisbəti 50%+ 10 ildə; müalicə bu prosesi sürətləndirir.

Mif 6: «Hipnoterapiya, ezoterik müdaxilələr şəxsiyyət pozuntularını sağaldır»

Sübut: sübut yoxdur; sübutlu strukturlaşdırılmış psixoterapiya tövsiyə edilir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D10 Şəxsiyyət pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik təlimat CG78. Sərhəd şəxsiyyət pozuntusu: tanınması və idarə edilməsi. 2009.
4. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik təlimat CG77. Antisosial şəxsiyyət pozuntusu: profilaktikası və idarə edilməsi. 2009.
5. Linehan M.M. və b. Sərhəd şəxsiyyət pozuntusu olan şəxslərdə yüksək intihar (suisid) riskinə görə dialektik davranış terapiyası: randomizə edilmiş klinik sınaq və komponent təhlili. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2015;72(5):475–482.
6. Bateman A., Fonagy P. Sərhəd şəxsiyyət pozuntusu üçün ambulator mentalizasiyaya əsaslanan müalicənin strukturlaşdırılmış klinik idarəetmə ilə müqayisəsinin randomizə edilmiş nəzarətli sınağı. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2009;166(12):1355–1364.
7. Zanarini M.C. və b. Sərhəd (borderline) şəxsiyyət pozuntusunun 10 illik gedişatının proqnozlaşdırılması. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2006;163(5):827–832.
8. Tayrer P., Rid Q.M., Kroford M.C. Şəxsiyyət pozuntusunun təsnifatı, qiymətləndirilməsi, yayılması və təsiri. «Lancet». 2015;385(9969):717–726.
9. Yanq C.E., Klosko C.S., Veyşar M.E. Sxem terapiyası: Praktik psixoterapevt üçün rəhbər. Nyu-York: Qilford Nəşriyyatı; 2003.

10. Yeomans F.E., Klarkin C.F., Kernberg O.F. Sərhəd (borderline) şəxsiyyət pozuntusu üçün transferə fokuslanmış psixoterapiya: Klinik rəhbər. Vaşinqton: Amerika Psixiatriya Nəşriyyatı; 2015.
11. Lenzenveger M.F., Leyn M.K., Loranqer A.V., Kessler R.K. DSM-IV şəxsiyyət pozuntuları Milli Komorbidlik Sorğusunun Təkrarında. «Bioloji Psixiatriya» (Biol Psychiatry). 2007;62(6):553–564.

XBT-11 **6D11**	**6D11 QABARIQ ŞƏXSİYYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ YA REAKSİYALARI** **Prominent personality traits or patterns**
XBT-10 —	XBT-10-da ekvivalenti yoxdur
DSM-5-TR F60.3	Sərhəd şəxsiyyət pozuntusu (yalnız 6D11.5 sərhəd nümunəsi kvalifikatoruna uyğundur)

1. Tərif və nozologiya

Qabarıq şəxsiyyət xüsusiyyətləri və ya reaksiyaları (ing. XBT-11: 6D11 Prominent personality traits or patterns) — müstəqil diaqnoz deyil, kvalifikatorlar dəstəsidir: şəxsiyyət pozuntusunun (6D10) və ya şəxsiyyət çətinliyinin hansı xüsusiyyət domenləri ilə təzahür etdiyini qeyd edir. Ağırlıq dərəcəsi 6D10-da, sahə isə burada kodlaşdırılır; 6D11 tək başına qoyulmur.

Şəxsiyyət çətinliyi (ing. Personality difficulty) XBT-11-də psixi pozuntu deyil — o, «Sağlamlıq vəziyyətinə təsir edən amillər» fəslində QE50.7 kodu ilə kodlaşdırılır. Şəxsiyyət xüsusiyyətləri funksional çətinlik yaradır, lakin 6D10 meyarlarına çatmır.

2. Tarixçə

- XBT-11 (2019) — kateqorial 10 şəxsiyyət pozuntusundan imtina; onların yerinə şiddət dərəcəsi (6D10) və beş xüsusiyyət sahə (6D11.0–6D11.4).
- 6D11.5 «sərhəd nümunəsi» ayrıca əlavə edildi — XBT-10-un sərhəd şəxsiyyət pozuntusunun (F60.3) davamı; DSM-5-TR-də isə buna yalnız III bölmənin ölçülü modeli uyğun gəlir.

3. Epidemiologiya

Dəqiq epidemioloji məlumat məhduddur; subklinik şəxsiyyət xüsusiyyətləri əhalidə geniş yayılmışdır.

4. Etiologiya və patogenez

6D10 ilə eyni — genetik və mühit qarşılıqlı təsiri.

5. Klinik təzahürlər

- 6D11.0 Mənfi affektivlik — geniş spektrli mənfi emosiyalar: narahatlıq, əsəbilik, özünə inamsızlıq, emosional labillik.
- 6D11.1 Təcrid — sosial və emosional uzaqlaşma: qaçınma, məhdud affekt, yaxınlıqdan imtina.
- 6D11.2 Dissosiallıq — başqalarının hüquq və hisslərinə etinasızlıq: eqosentrizm, Dissosiallıq — empatiya çatışmazlığı, eqosentrizm, istismarçılıq.
- 6D11.3 Dezinhibisiya — impulsivlik, diqqətsizlik, məsuliyyətsizlik, ani mükafata meyillilik.
- 6D11.4 Anankastiya — perfeksionizm, sərt qaydalar, emosional və davranış nəzarəti.
- 6D11.5 Sərhəd nümunəsi (borderline pattern) — münasibətlərin, mənlik obrazının və affektin qeyri-sabitliyi, impulsivlik, tərk edilmə qorxusu, özünəzərər və intihar davranışı.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Diaqnoz 6D10 (şəxsiyyət pozuntusu) və ya QE50.7 (şəxsiyyət çətinliyi) üzrə qoyulur; 6D11 yalnız kvalifikator kimi əlavə olunur.

B. Klinik əhəmiyyətli dərəcədə ifadə olunmuş bütün sahə qeyd edilir — onların sayı bir neçə ola bilər.

C. «Sərhəd nümunəsi» (6D11.5) istənilən sahə dəsti ilə birlikdə əlavə qeyd edilə bilər.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

XBT-11 — bu kateqoriya bir növ «şəxsiyyət problemlərinə dair klinik diqqət» koduna bənzəyir QE50.7 koduna bənzəyir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. 5 sahə qiymətləndirməsi.
3. Tam şəxsiyyət pozuntusu diaqnozunun istisna edilməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Şəxsiyyət pozuntusu (6D10)	Əhəmiyyətli funksional pozulma.
Uyğunlaşma pozuntusu (6B43)	Stress amilinə cavab.
Normal şəxsiyyət variantı	Funksional çətinlik yoxdur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

Şəxsiyyət şkalaları (PID-5).

8. Müalicə

1. Psixoterapiya — qısa-orta müddətli; problemyönümlü KDT və ya dəstəkləyici psixoterapiya
2. Stress idarəsi və başa çıxma bacarıqları.
3. Komorbid simptomlar üçün spesifik müdaxilə.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Alət 7-ci bölməyə (Müayinə və qiymətləndirmə) keçirilməlidir. — ölçülü şəxsiyyət şkalası.

9. Proqnoz

Müalicə ilə yaxşılaşma; sabit qalma və ya tam şəxsiyyət pozuntusuna keçid riski.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Şəxsiyyət çətinliyi əsl diaqnoz deyil»

Sübut: XBT-11-də rəsmi kod kimi mövcuddur; subklinik şəxsiyyət problemlərinə klinik diqqət yetirilməsini təmin edir.

Mif 2: «Şəxsiyyət çətinliyi mütləq şəxsiyyət pozuntusuna çevrilir»

Sübut: bəzi pasiyentlərdə tam şəxsiyyət pozuntusuna keçid müşahidə edilir, lakin əksəriyyətdə vəziyyət sabit qalır və ya yaxşılaşır.

Mif 3: «Yalnız dərmanla müalicə olunmalıdır»

Sübut: psixoterapiya birinci sıra; farmakoterapiya komorbid simptomlar üçün.

Mif 4: «Bu kateqoriya yalnız „narahat“ pasiyentləri damğalamaq üçündür»

Sübut: XBT-11 funksional çətinliyə klinik cavabı və klinik dəstəyi nəzərdə tutur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). 6D11 Nəzərəçarpan şəxsiyyət xüsusiyyətləri və ya nümunələri. 2024.
2. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). QE50.7 Şəxsiyyət çətinliyi. 2024.
3. Tayrer P. və b. «Lancet». 2015;385(9969):717–726.

6D30–6D3Z PARAFİLİK POZUNTULAR

Parafilik pozuntular

XBT-11 **6D30**	**6D30 EKSHİBİSİONİST POZUNTU** **Exhibitionistic disorder**
XBT-10 F65.2	Ekshibisionizm
DSM-5-TR F65.2	Ekshibisionist pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Ekshibisionist pozuntu (ing. XBT-11: 6D30 Exhibitionistic Disorder; DSM-5-TR: F65.2) — razılığı olmayan şəxslərin qarşısında genital orqanların açılmasından davamlı və ya intensiv cinsi həyəcan; pasiyent bu fantaziyalara, impulslara və ya davranışa cavab olaraq əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma yaşayır və ya bunu razılığı olmayan şəxslərə qarşı həyata keçirir.

2. Tarixçə

- Lasègue C. (1877) — «ekshibisionistlər» termini.
- DSM-III (1980) — rəsmi diaqnoz.
- DSM-5 (2013) — parafiliya (atipik cinsi maraq) ilə parafilik pozuntu (klinik əzab-əziyyət və ya başqalarına zərər) fərqləndirilməsi.
- WFSBP 2020 (Thibaut F. və b.) — parafilik pozuntular üçün beynəlxalq tövsiyə.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: kişilərdə 2–4%; qadınlarda nadir.
- Başlanğıc: yeniyetməlik və erkən yetkinlik.
- Komorbidlik: digər parafiliya (parafilik pozuntu pasiyentlərinin 50–80 %-də), ASP, maddə istifadəsi, TDP.

4. Etiologiya və patogenez

- Çoxsaylı amillər — bioloji, davranış şərtlənməsi, psixososial.
- Komorbid impulsivlik və hiperseksuallıq.

5. Klinik təzahürlər

- Razılığı olmayan şəxslərin qarşısında cinsiyyət orqanlarının açılması üçün təkrarlanan və intensiv cinsi həyəcan.
- Pasiyent fantaziya, impuls və ya davranışı icra edir və ya əzab-əziyyət yaşayır.
- Tipik şərait — küçə, ictimai nəqliyyat.
- Hüquqi və ictimai nəticələr (cinsi cinayət).

6. Diaqnoz

6.1 Diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR / XBT-11)

A. ≥ 6 ay təkrarlanan və intensiv cinsi həyəcan razılığı olmayan şəxslərin qarşısında cinsiyyət orqanlarının açılmasından.

B. Pasiyent fantaziyalarını və ya impulslarını icra etmiş və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət/funksional pozulma yaşayır.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — 6 aylıq müddət tələb edir; XBT-11-də müddət meyarı yoxdur — «davamlı, cəmlənmiş və intensiv cinsi həyəcan nümunəsi» deyilir.
- WFSBP 2020 — parafilik pozuntuların pillə-pillə müalicəsi.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Komorbidlik (ASP, maddə, başqa parafilik).
3. Risk qiymətləndirməsi (adli kontekst).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Hiperseksuallıq	Razılıq verən tərəfdaşlarla cinsi əlaqə.
Manik epizod	Affektiv kontekst.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Demensiya	Frontal lob patologiyası ilə bağlı disinhibisiya.
Maddə ilə törədilmiş	Toksikoloji.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Klinik müsahibə.
- Cinsi residiv riskinin qiymətləndirilməsi üçün risk şkalaları (Static-99R).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (WFSBP 2020 pillə-pillə)

1. KDT (koqnitiv-davranış terapiyası) və koqnitiv-davranış müdaxiləsi — birinci sıra; residivin qarşısının alınması, koqnitiv təhriflərin idarəsi.
2. SSGİ — yüksək dozada (fluoksetin 40–80 mq); impulsivlik və cinsi tələbatı azaldır.
3. Müqavimətli hallarda / ağır halda — antiandrogen (siproteron asetat — CPA, medroksiprogesteron asetat — MPA).
4. Ən ağır halda — qonadotropin-azadlaşdırıcı hormon (GnRH) agonistləri (leyprorelin, triptorelin) — kimyəvi kastrasiya; davamlı izləmə.
5. Hüquqi-tibbi əlaqələndirmə tələb olunur.

8.2 Müalicə metodikaları

1. KDT (residivin qarşısının alınması) — Tətikləyici idarəsi, koqnitiv distorsiya.
2. SSGİ yüksək dozada — birinci sıra farmakoterapiya.
3. Antiandrogen (CPA, MPA) — Refrakter halda.
4. GnRH Agonist — Ən ağır halda.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- WFSBP 2020 — pillə-pillə alqoritm.

9. Proqnoz

Sübutlu müalicə ilə residiv azalması; komorbid ASP və maddə pis proqnoz.

10. Geniş yayılmış yanlış inanclar

Mif 1: «Ekshibisionizm zərərsizdir»

Sübut: qurbana psixoloji travma; cinsi cinayət; daha ağır parafiliklərə inkişaf riski.

Mif 2: «Kimyəvi kastrasiya birinci sıra»

Sübut: WFSBP 2020 pillə-pillə — KDT və SSGİ əvvəl; GnRH ən ağır halda.

Mif 3: «Müalicə effektivsizdir»

Sübut: KDT və farmakoterapiya residiv riskini əhəmiyyətli azaldır.

Mif 4: «Yalnız hüquqi cəza tələb olunur»

Sübut: klinik müdaxilə residiv riskini azaldır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). 6D30 Ekshibisionizm pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı» (DSM-5-TR). 2022.
3. Tibo F., Kosins P., Fedoroff C.P. və b.; Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) Parafiliyalar üzrə İşçi Qrupu. Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) parafilik pozuntuların farmakoloji müalicəsi üzrə 2020 təlimatları. «Dünya Bioloji Psixiatriya Jurnalı» (World J Biol Psychiatry). 2020;21(6):412–490.

XBT-11 **6D31**	**6D31 VOYEURİSTİK POZUNTU** **Voyeuristic disorder**
XBT-10 F65.3	Voyerizm
DSM-5-TR F65.3	Voyerist pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Voyeuristik pozuntu (ing. XBT-11: 6D31 Voyeuristic Disorder; DSM-5-TR: F65.3) — razılığı olmayan şəxslərə soyunma, çılpaq olma, cinsi fəaliyyət zamanı gizli baxmaqdan davamlı və intensiv cinsi həyəcan; pasiyent bu fantaziyalara cavab olaraq əzab-əziyyət yaşayır və ya bunu razılığı olmayan insanlarda gerçəkləşdirir.

2. Tarixçə

Voyerizm klinik ədəbiyyatda ekshibisionizmlə (6D30) paralel təsvir edilmişdir.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: pozuntunun əhalidə yayılması məlum deyil; DSM-5-TR qeyri-klinik seçmələrdə voyeristik hərəkətlərə əsaslanaraq mümkün ən yüksək ömürlük yayılmanı kişilərdə təxminən 12%, qadınlarda təxminən 4% kimi göstərir (Långström N., Seto M.C. Arch Sex Behav 2006, n = 2450). Voyeristik davranışı olanların əksəriyyəti pozuntu meyarlarını qarşılamır.
- Komorbid başqa parafilik pozuntular.
- İnternet voyeurizm (gizli kamera, «yuxarıdan çəkiliş» (upskirt)) inkişaf etməkdədir.

4. Etiologiya və patogenez

Parafilik pozuntular üçün ümumi etiologiya.

5. Klinik təzahürlər

- Razılığı olmayan şəxslərə soyunmuş və ya cinsi fəaliyyət zamanı gizli baxma.
- Tipik kontekst — pəncərə, soyunma otaqları, ictimai yerlər.
- «Yuxarıdan çəkiliş» (upskirting) müasir formasıdır.
- Hüquqi nəticələr.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. ≥ 6 ay razılığı olmayan şəxslərə baxmaqdan davamlı və intensiv cinsi həyəcan.

B. Pasiyent fantaziyanı icra etmiş və ya əzab-əziyyət yaşayır.

C. Yaş ≥ 18 (DSM-5-TR; yeniyetmələrdə normal maraq istisnadır).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — 6 aylıq müddət tələb edir; XBT-11-də müddət meyarı yoxdur — «davamlı, cəmlənmiş və intensiv oyanma nümunəsi» deyilir.
- WFSBP 2020.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Komorbidlik.
3. Risk qiymətləndirməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Yeniyetmə maraq	Normal inkişaf hissəsi.
Razılıqlı seyrçilik (porno)	Razılıqlı kontekst.
Manik epizod	Affektiv kontekst.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Klinik müsahibə.
- Risk şkalaları.

8. Müalicə

1. WFSBP 2020 pillə-pillə alqoritm (6D30 ilə eyni):
    - KDT residivin qarşısının alınması;
    - SSGİ yüksək doza;
    - Antiandrogen;
    - GnRH ən ağır halda.
2. Hüquqi-tibbi koordinasiya.

8.1 Müalicə metodikaları

6D30 ilə eyni.

9. Proqnoz

Sübutlu müalicə ilə residiv azalması.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Voyerizm zərərsizdir, qurban xəbərsiz qalır»

Sübut: qurban aşkar olduqda travma; razılığın pozulması cinsi cinayətdir.

Mif 2: «Pornoqrafiya istifadəsi voyerizmdir»

Sübut: razılıqlı istehsal və istehlak — voyerizm yox; klinik diaqnoz razılığı olmayan şəxslərə yönəlir.

Mif 3: «Yalnız internet voyerizmi yenidir, klinik əhəmiyyət yoxdur»

Sübut: «upskirting», gizli kamera — cinsi cinayət; klinik və hüquqi müdaxilə tələb olunur.

Mif 4: «Müalicə effektivsizdir»

Sübut: KDT və farmakoterapiya effektivdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). 6D31 Voyyerizm pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı» (DSM-5-TR). 2022.
3. Tibo F., Kosins P., Fedoroff C.P. və b.; Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) Parafiliyalar üzrə İşçi Qrupu. Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) parafilik pozuntuların farmakoloji müalicəsi üzrə 2020 təlimatları. «Dünya Bioloji Psixiatriya Jurnalı» (World J Biol Psychiatry). 2020;21(6):412–490.
4. Lonqström N., Seto M.K. İsveç milli əhali (populyasiya) sorğusunda ekshibisionist və voyyeristik davranış. «Cinsi Davranış Arxivləri» (Arch Sex Behav). 2006;35(4):427–435.

XBT-11 **6D32**	**6D32 PEDOFİLİK POZUNTU** **Pedophilic disorder**
XBT-10 F65.4	Pedofiliya

XBT-11 **6D32**	**6D32 PEDOFİLİK POZUNTU** **Pedophilic disorder**
DSM-5-TR F65.4	Pedofil pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Pedofilik Pozuntu (ing. XBT-11: 6D32 Pedophilic Disorder; DSM-5-TR: F65.4) — prepubertat uşaqlara (tipik 13 yaş və ya daha kiçik) qarşı davamlı və intensiv cinsi həyəcan ≥ 6 ay; pasiyent fantaziyalara cavab olaraq uşaqlarla cinsi əlaqə icra etmiş və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət/funksional pozulma yaşayır. Pasiyent ən azı 16 yaşda və qurbanından ən azı 5 yaş böyük.

Vacib: «Pedofilik maraq» (parafiliya) və «pedofilik pozuntu» (klinik diaqnoz) fərqlidir — diaqnoz funksional pozulma və/yaxud uşağa zərər tələb edir.

2. Tarixçə

- Krafft-Ebing (1886).
- DSM-III (1980).
- WFSBP 2020 — beynəlxalq parafilik göstərişi.

3. Epidemiologiya

- Yayılma — dəqiq məlumat çətindir (stigmatik kateqoriya); DSM-5-TR kişi əhalisində ən yüksək mümkün göstərici kimi 3–5% verir; həqiqi pedofil üstünlüyü təxminən 1%.
- Cins: demək olar ki, həmişə kişilərdə müşahidə olunur.
- Komorbidlik: başqa parafilik, ASP, TDP, narahatlıq, maddə istifadəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- Bioloji — neyroinkişaf anomaliyaları (Cantor J.M. icmalları — IQ, neyroanatomik fərqlər).
- Uşaqlıq travması və ya cinsi zorakılıq tarixçəsi (lakin əksər pedofilik pozuntulu şəxslər özləri qurban olmamışdır; «zorakılıq dövranı» (abused-abuser) anlayışıdır).

- Komorbid impulsivlik və hiperseksuallıq.

5. Klinik təzahürlər

- Prepubertat uşaqlara qarşı davamlı və intensiv cinsi həyəcan.
- Pasiyent fantaziya icra edib (uşağa cinsi zorakılıq) və ya əzab-əziyyət/funksional pozulma yaşayır.
- Alt-tiplər (DSM-5-TR): yalnız uşaqlara cəlb (ing. exclusive type), həm uşaqlara həm yetkinlərə (nonexclusive); kişi/qadın/hər ikisi.
- Hüquqi nəticələr (cinayət).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. ≥ 6 ay prepubertat uşaqlara (tipik ≤ 13) qarşı təkrarlanan və intensiv cinsi həyəcan.

B. Pasiyent fantaziyanı icra etmiş və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət/funksional pozulma yaşayır.

C. Pasiyent ≥ 16 yaşında, qurbandan ≥ 5 yaş böyük olmalıdır.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — 6 aylıq müddət və yaş qaydası (pasiyent ≥ 16 yaş və uşaqdan ≥ 5 yaş böyük) tələb edir; XBT-11-də nə müddət, nə də yaş meyarı yoxdur — yalnız yaşca yaxın həmyaşıdlar arasındakı davranış istisna edilir.
- WFSBP 2020.
- Adli psixiatriya kontekstində struktur risk qiymətləndirməsi.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (etiraf çətin; pasiyent gizlədə bilər).
2. Penil pletizmografiya tədqiqat və adli şəraitdə istifadə olunur.
3. Adli risk qiymətləndirməsi (Static-99R, STABLE-2007).
4. Komorbidlik.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Maddə ilə törədilmiş disinhibisiya	Toksikoloji.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Demensiya (frontal)	Koqnitiv funksiyaların azalması, nevroloji əlamətlər.
İntellektual inkişaf pozuntusu	Koqnitiv çatışmazlıq kontekstdə.
Hiperseksuallıq yetkinlərə	Pedofilik fokus yox.
«hebefiliya» (hebephilia) / «efebofiliya» (ephebophilia)	Pubertat və post-pubertatlara fokus; DSM-5-TR-də ayrı kateqoriya yoxdur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Adli klinik müsahibə.
- Riski qiymətləndirmə alətləri: Static-99R və STABLE-2007.
- Penil pletizmografiya (araşdırma).
- Komorbidlik.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (WFSBP 2020 pillə-pillə)

1. KDT və residivin qarşısının alınması — birinci sıra; tətikləyici idarəsi, koqnitiv distorsiya idarəsi, empati inkişafı.
2. SSGİ yüksək dozada — birinci farmakoterapiya — impulsivlik və cinsi tələbatı azaldır.
3. Antiandrogen (CPA, MPA) — orta-ağır halda; libido və cinsi fəaliyyət azalır.
4. GnRH agonist (leuprolid, triptorelin) — kimyəvi kastrasiya; ən ağır və ya yüksək risk halda; davamlı izləmə (osteoporoz, metabolik pozuntular).
5. Adli müdaxilə və icma izləməsi paralel.
6. Multidissiplinar yanaşma — psixiatr, terapevt, sosial xidmət, hüquqi.

8.2 Müalicə metodikaları

1. KDT və Residivin qarşısının alınması (relapse prevention) tətikləyici və şərait idarəsi; koqnitiv distorsiya; empati təlimi.
2. SSGİ Yüksək Doza — Birinci farmakoterapiya.
3. Antiandrogen (CPA, MPA) — Libido azaltma.
4. GnRH Agonist — Kimyəvi kastrasiya; davamlı izləmə.
5. Static-99R, STABLE-2007 — Adli risk qiymətləndirmə.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- WFSBP 2020 — Thibaut və b. — pillə-pillə farmakoterapiya.
- STABLE-2007 — dinamik risk amilləri.

9. Proqnoz

- Sübutlu müalicə ilə davranışa nəzarət yaxşılaşır.
- Komorbid ASP və maddə istifadəsi — pis proqnoz.
- Davamlı izləmə kritik.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pedofilik maraq həmişə uşağa zorakılıq deməkdir»

Sübut: «pedofilik fantaziyaya malik olmaq» və «uşağa zorakılıq etmək» fərqlidir; bəzi pasiyentlər heç vaxt zorakılıq etmir və klinik dəstək axtarır («Dunkelfeld» Almaniya proqramı kimi).

Mif 2: «Bütün uşaq cinsi zorakılığı törədənlər pedofilikdir»

Sübut: əksər uşaq cinsi zorakılığı törədənlər pedofilik deyil situativ xarakterli olub, başqa motivasiya ilə bağlıdır. Pedofilik diaqnoz ≥ 6 ay davamlı cinsi həyəcan tələb edir.

Mif 3: «Kimyəvi kastrasiya bütün pasiyentlər üçün məcburi olmalıdır»

Sübut: WFSBP 2020 pillə-pillə yanaşma — GnRH ən ağır halda; KDT və SSGİ əvvəl. Etik və hüquqi ehtiyat.

Mif 4: «„Bir dəfə pedofilik — həmişə pedofilik“»

Sübut: cinsi maraq stabil ola bilər, lakin davranışa nəzarət KDT və farmakoterapiya ilə əhəmiyyətli yaxşılaşa bilər.

Mif 5: «Müalicə effektivsizdir»

Sübut: WFSBP 2020 və meta-analizlər — multimodal müdaxilə residiv riskini azaldır.

Mif 6: «Pasiyent uşaqlıq travmasının „qurbanı“dır»

Sübut: «zorakılıq dövranı» (abused-abuser) anlayışı tam dəstəklənmir; əksər pasiyent uşaqlıqda zorakılığa məruz qalmamışdır; uşaqlıqda qurban olmaq törətməyə əsas vermir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). 6D32 Pedofiliya pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı» (DSM-5-TR). 2022.
3. Tibo F., Kosins P., Fedoroff C.P. və b.; Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) Parafiliyalar üzrə İşçi Qrupu. Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) parafilik pozuntuların farmakoloji müalicəsi üzrə 2020 təlimatları. «Dünya Bioloji Psixiatriya Jurnalı» (World J Biol Psychiatry). 2020;21(6):412–490.
4. Kantor C.M. və b. Pedofil kişilərdə serebral ağ maddə çatışmazlıqları. «Psixiatriya Tədqiqatları Jurnalı» (J Psychiatr Res). 2008;42(3):167–183.
5. Bayer K.M. və b. Özünü pedofil və hebefil kimi müəyyən edən şəxslərin peşəkar köməyə müraciətinin təşviqi (Dunkelfeld Qabaqlayıcı Layihəsi). «Uşaqlara qarşı zorakılıq və laqeydlik» (Child Abuse Negl). 2009;33(8):545–549.

XBT-11 **6D33**	**6D33 MƏCBURİ CİNSİ SADİZM POZUNTUSU** **Coercive sexual sadism disorder**
XBT-10 F65.5	Sadomazoxizm
DSM-5-TR F65.52	Cinsi sadizm pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Məcburi Cinsi Sadizm Pozuntusu (ing. XBT-11: 6D33 Coercive Sexual Sadism Disorder; DSM-5-TR: F65.52 Sexual Sadism Disorder) — razılığı olmayan şəxsə fiziki və ya psixoloji əzab verməkdən davamlı və intensiv cinsi həyəcan. Pasiyent fantaziya icra etmiş və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət/funksional pozulma yaşayır.

Vacib fərq: razılıqla BDSM (Bondage/Discipline, Dominance/Submission, Sadism/Masochism) təcrübəsi klinik pozuntu deyil; XBT-11 bu fərqi vurğulayır.

2. Tarixçə

- Krafft-Ebing (1886) — sadizm termini Marquis de Sade-dən.

- DSM-5 (2013) — parafiliya ilə parafilik pozuntu arasındakı fərq.
- XBT-11 (2019) — «məcburedici» (ing. coercive) sözü razılıq vacibliyini vurğulayır.
- WFSBP 2020.

3. Epidemiologiya

- Klinik əhalidə nadir; adli şəraitdə cinsi cinayət hallarının 5–15 %-ində.
- Demək olar həmişə kişilərdə.
- Yüksək komorbidlik ASP, başqa parafilik pozuntular.

4. Etiologiya və patogenez

- Bioloji və psixososial amillər; uşaqlıq travması, antisosial xüsusiyyətlər.
- Hiperseksuallıq və impulsivlik tez-tez komorbidlik təşkil edir.

5. Klinik təzahürlər

- Razılığı olmayan qurbana əzab verməkdən cinsi həyəcan.
- Tipik şərait — zorlama-sadistik cinayət.
- Ağır halda — sadistik qətllər, ciddi fiziki yaralanma.
- Adli risk yüksək.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. ≥ 6 ay razılığı olmayan şəxsə fiziki və ya psixoloji əzabdan davamlı və intensiv cinsi həyəcan.

B. Pasiyent fantaziyanı icra etmiş və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət yaşayır.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — 6 aylıq müddət tələb edir; XBT-11-də müddət meyarı yoxdur — «davamlı, cəmlənmiş və intensiv cinsi həyəcan nümunəsi» kimi təsvir olunur.
- Razılıqlı BDSM klinik pozuntu deyil.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Adli klinik müsahibə.

2. Risk qiymətləndirməsi (Static-99R, SVR-20).
3. Komorbid pozuntular (ASP, psixopatiya — PCL-R).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Razılıqlı BDSM	Razılıqlı kontekst — pozuntu deyil.
ASP	Cinsi komponent olmadan zorakılıq.
Psixopatiya	PCL-R; klinik üst-üstə düşmə.
Maddə induksiyalı	Toksikoloji.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Adli klinik müsahibə.
- PCL-R (Psixopatiya Yoxlama Siyahısı), Static-99R, SVR-20.

8. Müalicə

1. WFSBP 2020 pillə-pillə alqoritm:
    - KDT və residivin qarşısının alınması;
    - SSGİ yüksək doza;
    - Antiandrogen;
    - GnRH agonist ən ağır halda.
2. Adli psixiatriya nəzarəti; xəstəxanaya yerləşdirmə və ya cəzaçəkmə müəssisəsində müalicə.
3. Psixopatiya komorbid hallarda standart psixoterapiya az effektivdir.

8.1 Müalicə metodikaları

1. KDT və Residiv Profilaktikası (ing. Relapse Prevention) — Təsirliliyi məhduddur; psixopatiya fonunda daha da azalır.
2. SSGİ, antiandrogenlər və GnRH agonistləri — WFSBP 2020 pillə-pillə ardıcıllıqla.
3. PCL-R, Static-99R, SVR-20 — Adli risk qiymətləndirmə.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- WFSBP 2020 — ağır halda kombinasiya (KDT + antiandrogen + GnRH).

9. Proqnoz

Ağır halda yüksək residiv riski; multimodal müdaxilə və davamlı izləmə vacibdir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «BDSM = sadistik pozuntu»

Sübut: razılıqlı BDSM klinik pozuntu deyil; XBT-11 bunu məcburilik (ing. coercive) əlaməti ilə dəqiq fərqləndirir. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA) və digər peşəkar birliklər razılıqlı BDSM-i patologiya hesab etmir.

Mif 2: «Sadistik pozuntu müalicə oluna bilməz»

Sübut: WFSBP 2020 — multimodal müdaxilə residiv riskini azaldır; psixopatiya komorbid halda effekt daha az.

Mif 3: «Yalnız hüquqi cəza tələb olunur»

Sübut: klinik müdaxilə hüquqi nəzarətlə birgə tövsiyə olunur.

Mif 4: «Bütün cinsi qatillər sadistik pozuntuludur»

Sübut: əksər cinsi cinayət ASP və ya başqa motivasiyalıdır; sadistik klinik diaqnoz konkret fantaziya nümunəsi tələb edir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). 6D33 Məcburi cinsi sadizm pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı» (DSM-5-TR). 2022.
3. Tibo F., Kosins P., Fedoroff C.P. və b.; Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) Parafiliyalar üzrə İşçi Qrupu. Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) parafilik pozuntuların farmakoloji müalicəsi üzrə 2020 təlimatları. «Dünya Bioloji Psixiatriya Jurnalı» (World J Biol Psychiatry). 2020;21(6):412–490.
4. Hare R.D. Psixopatiya Yoxlama Siyahısı — Yenidən işlənmiş variant (PCL-R). 2-ci nəşr. 2003.

XBT-11 **6D34**	**6D34 Frotterist pozuntu (ing. frotteuristic disorder)** **Frotteuristic disorder**
XBT-10 F65.8	Cinsi seçimin digər pozuntuları
DSM-5-TR F65.81	Frotterist pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Frotteristik Pozuntu (ing. XBT-11: 6D34 Frotteuristic Disorder; DSM-5-TR: F65.81) — razılığı olmayan şəxsə toxunma və ya öz cinsiyyət orqanlarını sürtməkdən davamlı və intensiv cinsi həyəcan. Pasiyent fantaziya icra etmiş və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət/funksional pozulma yaşayır. Tipik şərait — sıx ictimai nəqliyyat və izdihamlı yerlər.

2. Tarixçə

- «Frotteur» — fransız sözündən «sürtən».
- DSM-IV (1994) — «başqa cür dəqiqləşdirilməmiş cinsi pozuntu» (302.9); DSM-5 (2013) — ayrı kateqoriya.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: frotterist hərəkətlər yetkin kişilərin 30 %-də rast gəlinir; parafiliya və hiperseksuallıq üzrə ambulator müraciət edən kişilərin 10–14%-i pozuntu meyarlarına uyğun gəlir (DSM-5-TR).
- Komorbid başqa parafilik pozuntular.

4. Etiologiya və patogenez

Parafiliyalar üçün ümumi etiologiya; komorbid hiperseksuallıq və impulsivlik.

5. Klinik təzahürlər

- İzdihamlı ictimai yerlərdə (avtobus, metro, izdiham) razılığı olmayan şəxsə toxunma.
- Pasiyent qaçır — qurban dərhal şikayət edə bilmir.

- Hüquqi nəticələr (cinsi təcavüz (ing. sexual harassment), cinsi cinayət).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. ≥ 6 ay razılığı olmayan şəxsə toxunma və ya sürtməkdən davamlı və intensiv cinsi həyəcan.

B. Pasiyent fantaziyanı icra etmiş və ya əhəmiyyətli əzab-əziyyət yaşayır.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

DSM-5-TR / XBT-11 — eyni; WFSBP 2020.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Risk qiymətləndirməsi.
3. Komorbidlik.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Təsadüfi toxunma (sıx izdihamda)	Razılıq problemi və fantaziya yoxdur.
ASP	Geniş antisosial model.
Manik epizod	Affektiv kontekst.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Adli klinik müsahibə.
- Risk şkalaları.

8. Müalicə

1. WFSBP 2020 pillə-pillə:
    - KDT və residivin qarşısının alınması;
    - SSGİ yüksək doza;
    - Antiandrogen / GnRH ağır halda.
2. Hüquqi-tibbi koordinasiya.

8.1 Müalicə metodikaları

1. KDT və SSGİ — WFSBP 2020 protokolu; 6D30, 6D31 və 6D32 ilə eyni pillə-pillə ardıcıllıq.

9. Proqnoz

WFSBP müdaxiləsi ilə residiv azalması.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Frotteurizm zərərsizdir»

Sübut: qurban üçün travmadır; cinsi cinayət və hüquqi nəticələr.

Mif 2: «Yalnız impuls — klinik müdaxilə tələb etmir»

Sübut: təkrarlanan paterni klinik diaqnoz tələb edir.

Mif 3: «Yalnız hüquqi cəza»

Sübut: klinik müdaxilə residiv riskini azaldır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). 6D34 Frottörizm pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı» (DSM-5-TR). 2022.
3. Tibo F., Kosins P., Fedoroff C.P. və b.; Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) Parafiliyalar üzrə İşçi Qrupu. Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının (WFSBP) parafilik pozuntuların farmakoloji müalicəsi üzrə 2020 təlimatları. «Dünya Bioloji Psixiatriya Jurnalı» (World J Biol Psychiatry). 2020;21(6):412–490.

6D50–6D5Z Süni pozuntular

Süni pozuntular (factitious disorders)

XBT-11 **6D50**	**6D50 ÖZÜNƏ TƏTBİQ EDİLƏN SÜNİ POZUNTU (faktisioz)** **Factitious disorder imposed on self**
XBT-10 F68.1	Simptomların, fiziki və ya psixoloji xarakterli əlilliyin qəsdən törədilməsi və ya təqlid edilməsi [Süni pozuntular]
DSM-5-TR F68.10	Özünə tətbiq edilən SÜNİ POZUNTU

1. Tərif və nozologiya

Özünə tətbiq edilən SÜNİ POZUNTU (ing. XBT-11: 6D50; DSM-5-TR: F68.10 Factitious Disorder Imposed on Self) — pasiyentin özündə fiziki və ya psixoloji simptomları və ya zədəni qəsdli yaratması, bu simptomları başqalarına təqdim etməsi; aşkar maddi qazanc yoxdur — simulyasiyadan fərqi məhz bundadır. Pasiyentin əsas motivasiyası tibbi rola və ya xəstə kimi qəbul olunmaqdır.

2. Tarixçə

- Asher R. (1951) — «Munchausen syndrome» termini (Baron Munchausen-in fantastik hekayələrindən).
- DSM-III (1980) — Factitious Disorder rəsmi diaqnoz kimi təsbit edilib.
- DSM-5 (2013) — «Imposed on Self» və «Imposed on Another» alt-tiplər.
- Eisendrath S.J. icmalları — diaqnoz və klinik yanaşma.

3. Epidemiologiya

- əhalidə nadir (1–2 % xəstəxanaya yatırılma); praktikada diaqnozun az qoyulması.
- Cins: qadınlarda nisbətən yüksək (tibbi peşə fonunda).
- Komorbidlik: ŞPP, depressiv pozuntular, travma tarixçəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- Psixoloji — xəstə rolunda dərin emosional ehtiyac; uşaqlıq travması, qayğısızlıq.
- Tibbi sistemə yaxınlıq (tibb işçisi olmaq).
- ŞPP komorbid sıx.

5. Klinik təzahürlər

- Çoxsaylı tibbi müraciətlər və yoxlamalar; çoxsaylı klinika dəyişdirmə (ing. «hospital shopping» — xəstəxana axtarışı).
- Çoxsaylı cərrahi prosedurlar.
- Simptom və ya zədənin qəsdli yaradılması (qan tökmə, infeksiya yaratma, dərmanla zəhərlənmə, somatik şikayət uydurma).
- Klinik mənzərə «mümkünsüz» və ya atipik; laboratoriya nəticələri pasiyentin şikayətləri ilə uyğun gəlmir.
- Pasiyent müsahibədə yalan danışa bilər; tarixçə etibarsızdır.
- Aşkar maddi qazanc yoxdur (sığorta, məhkəmə, iş).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Özündə fiziki və ya psixoloji simptom və ya zədənin qəsdli yaradılması (yaradılmış və ya uydurulmuş).

B. Pasiyent özünü xəstə, yaralı kimi təqdim edir.

C. Aldatma davranışı aşkar maddi qazancla bağlı deyil.

D. Davranış başqa psixi pozuntu (sayıqlama pozuntusu, başqa psixotik pozuntu) ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — eyni.
- Diaqnoz çətindir — sübut tələb edir (sığorta sənədləri, başqa klinikadan məlumat, video).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik şübhə — atipik klinik təzahürlər, çoxsaylı klinikalara müraciət, «mümkünsüz» simptom.

2. Başqa klinikalardan tibbi tarixçə əldə etmə (pasiyentin razılığı ilə).
3. Sığorta və əczaçılıq qeydləri.
4. Müşahidə — laborator nümunələrin yaradılma yolu.
5. Komorbid ŞPP, TDP, travma tarixçəsi.
6. Hüquqi və etik koordinasiya.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Real tibbi xəstəlik	Klinik təsdiq; lakin süni pozuntu komorbid ola bilər (kompleks hallar).
Somatik simptom pozuntusu (6C20)	Şüurlu yalan yox; pasiyent simptomları real hiss edir.
Konversion (6B60)	Şüurlu yox; sinir sisteminin funksional pozulması.
Simulyasiya	Aşkar maddi və ya hüquqi qazanc (sığorta, məhkəmə).
Somatik sayıqlama pozuntusu	Xəstəliyini dərk etmə yoxdur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Tibbi tarixçə (başqa klinikalardan).
- Sığorta qeydləri.
- Psixiatrik müsahibə komorbid pozuntular üçün.

8. Müalicə

1. Qeyri-konfrontasiya yanaşması (Qeyri-konfrontasiya yanaşması (ing. non-confrontational approach, Eisendrath)) — diaqnoz pasiyentə cəza əvəzinə qayğı çərçivəsində izah edilir; «sizin əziyyətiniz reallıdır, başqa yolla kömək edə bilərik».
2. Tək həkim modeli — bütün şikayətlər həmin həkim vasitəsilə.
3. İnvaziv prosedurların və lazımsız yoxlamaların məhdudlaşdırılması.
4. Psixoterapiya — supportiv, koqnitiv-davranış terapiyası (KDT); uzunmüddətli izləmə.
5. Komorbid ŞPP, TDP, travma müalicəsi.

6. Konfrontasiya pasiyentin müalicədən uzaqlaşmasına səbəb olur; yumşaq yanaşma qayğı kontekstində daha effektivdir.

8.1 Müalicə metodları

1. Dəstəkləyici psixoterapiya — pasiyentin emosional ehtiyaclarına diqqət yetirilir.
2. Multidissiplinar yanaşma — tibbi və psixiatrik yanaşmanın birgə tətbiqi.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Eisendrath S.J. — qeyri-konfrontasiya yanaşması və terapevtik ittifaq.
- APA Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry (Levenson).

9. Proqnoz

- Xronik gediş; «hospital shopping» davam edir.
- Uzunmüddətli terapevtik ittifaq və komorbid pozuntuların müalicəsi proqnozu yaxşılaşdırır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Pasiyent „yalançı“dır, hüquqi cəza tələb olunur»

Sübut: SÜNİ POZUNTU psixiatrik pozuntudur — emosional ehtiyaca cavab; konfrontasiyasız yanaşma və psixoterapiya tövsiyə edilir.

Mif 2: «Birbaşa „yalan deyirsən“ deyilməsi pasiyenti dəyişər»

Sübut: sərt konfrontasiya pasiyenti «qovur» və başqa klinikaya keçirir; yumşaq yanaşma terapevtik ittifaq qurur.

Mif 3: «SÜNİ POZUNTU = somatik simptom pozuntusu»

Sübut: süni pozuntu şüurlu yalan; somatik simptom — pasiyentin gerçək hissi.

Mif 4: «Başlanmış invaziv prosedurlar sona qədər davam etdirilməlidir»

Sübut: lazımsız invaziv prosedurlar zərərlidir; diaqnoz qoyulduqdan sonra məhdudlaşdırılmalıdır.

Mif 5: «SÜNİ POZUNTU müalicə oluna bilməz»

Sübut: sübut bazası məhduddur, lakin uzunmüddətli terapevtik ittifaq və multidissiplinar qayğı ilə yaxşılaşma mümkündür.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). «Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı» (XBT-11). 6D50 Özünə qarşı yönəlmiş süni pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). «Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı» (DSM-5-TR). 2022.
3. Ayzendrat S.C. Süni somatik pozuntular: qarşıdurmasız müalicə. «Psixosomatika» (Psychosomatics). 1989;30(4):383–387.
4. Levenson C.L. (red.). Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA) Nəşriyyatının Psixosomatik Təbabət və Konsultasiya-Əlaqə Psixiatriyası üzrə Dərsliyi. 3-cü nəşr. 2018.
5. Aşer R. Münchhauzen sindromu. «Lancet». 1951;1(6650):339–341.

XBT-11 **6D51**	**6D51 BAŞQASINA TƏTBİQ EDİLƏN SÜNİ POZUNTU** **Factitious disorder imposed on another**
XBT-10 F68.1	Simptomların, fiziki və ya psixoloji xarakterli əlilliyin düşünülmüş şəkildə törədilməsi və ya simulyasiyası [Süni pozuntular]
DSM-5-TR F68.A	Başqasına tətbiq edilən SÜNİ POZUNTU

1. Tərif və nozologiya

Başqasına tətbiq edilən SÜNİ POZUNTU (ing. XBT-11: 6D51 Factitious Disorder Imposed on Another; DSM-5-TR: F68.A) — pasiyentin başqa şəxsdə (tipik olaraq öz uşağında, yaxud himayəsində olan yaşlı və ya əlil şəxsdə) fiziki və ya psixoloji simptom yaratması və ya uydurması; o şəxsi qurban kimi xəstəxanaya gətirir. Əvvəlcə «Munchausen sindromu (proxy forması)» (ing. Munchausen syndrome by proxy; Meadow R., 1977) adlandırılırdı.

Diaqnoz pasiyentə qoyulur, qurbana yox. Bu pozuntu eyni zamanda uşaq istismarıdır — uşaq qoruma və hüquqi müdaxilə mütləqdir.

2. Tarixçə

- Meadow R. (1977) — «Munchausen syndrome by proxy» Lancet.
- DSM-IV (1994) — tədqiqat kateqoriyası kimi verilmişdi.
- DSM-5 (2013) — rəsmi diaqnoz.
- APSAC, AAP — uşaq qoruma protokolları.

3. Epidemiologiya

- Nadir — illik insidens təxminən 2/100 000 uşaq (Sheridan M.S. Child Abuse Negl 2003 icmal); diaqnozun az qoyulması.
- Tipik fail — bioloji ana (90 %-dən çox); qurban — uşaq (adətən 5 yaşdan kiçik).
- Qurbanların mortaliteti 6–9% (Sheridan); morbidlik yüksəkdir.

4. Etiologiya və patogenez

- Failin psixoloji ehtiyacları — tibbi rolda diqqət, münasibətlər, «qəhrəman» obrazı.
- Tibbi peşə fonunda sıxlıq.
- Failin tarixçəsində travma və ya qayğısızlıq.

5. Klinik təzahürlər

- Uşağın simptomları yalnız anasının yanında baş verir; hospitalizasiya zamanı ana ayrı olduqda yaxşılaşır.
- Çoxsaylı klinika, atipik simptomlar, «mümkünsüz» tibbi tarixçə.
- Ana tibb işçisidir və ya geniş tibbi biliyə malikdir.
- Ana həddindən artıq nəzakətli və «ideal qayğı göstərən» görünür.
- Tipik induksiya metodları: dərmanla zəhərlənmə, qida və ya tənəffüs yolunun mexaniki bağlanması, qan toplanması, infeksiya yaratma.
- Qurban uşaqda izahsız təkrarlanan tutmalar, apnoe, hipoglikemiya, infeksiya, dəri zədəsi.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Pasiyentin başqasında (qurban) fiziki və ya psixoloji simptom və ya zədənin qəsdli yaradılması.

B. Pasiyent qurbanı xəstə, yaralı kimi başqalarına təqdim edir.

C. Aldatma davranışı aşkar maddi qazancla bağlı deyil.

D. Davranış başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

Diaqnoz failə qoyulur, qurbana yox.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — eyni.
- APSAC, AAP — uşaq qoruma protokolları; bu klinik vəziyyət eyni zamanda uşaq istismarı kateqoriyasıdır.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik şübhə — atipik simptom xarakteri, anaya bağlı simptomlar.
2. Pediatr, psixiatr, sosial işçi multidissiplinar qrup.
3. Tibbi sənədləşmənin başqa klinikalardan əldə edilməsi.
4. Ayrılma sınağı — ana qurbandan ayrı olduqda simptomların izlənməsi.
5. Video monitorinq (uşaq qoruma və hüquqi müdaxilə altında).
6. Toksikoloji və biokimyəvi testlər (simptomların qəsdli yaradılmasının sübutu).
7. Uşaq qoruma müraciəti və hüquqi koordinasiya mütləqdir.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Real tibbi xəstəlik	Tibbi sübut.
Həddindən artıq narahat valideyn	Qəsdli induksiya yox; tibbi şübhələri ifadə edir, lakin yaratmır.
Real uşaq istismarı (başqa form)	Fiziki istismar, cinsi istismar, qayğısızlıq — fərqli motivasiya.
Özünə tətbiq edilən SÜNİ POZUNTU (6D50)	Qurban özüdür.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Pediatr tərəfindən klinik qiymətləndirmə aparılır.
- Tibbi tarixçə qrup ilə.
- Sosial xidmət və uşaq qoruma müraciəti.

- Hüquqi koordinasiya.

8. Müalicə

1. Qurbanın təhlükəsizliyi birinci prioritetdir — uşağın ayrılması (ana və ya qayğı göstərəndən).
2. Uşaq qoruma müraciəti — hüquqi protokollar.
3. Pasiyentin (failin) psixiatrik müalicəsi:
    - Psixoterapiya (uzunmüddətli);
    - Komorbid pozuntular (ŞPP, TDP, travma);
    - Tibbi peşə fonunda — peşə qadağası nəzərdən keçirilə bilər.
4. Ailə müdaxiləsi və qardaş-bacıların qoruma qiymətləndirməsi.
5. Qurban uşağın psixoterapiyası — travma müdaxiləsi.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Uşaq Qoruma Müraciəti — Şübhə olduqda mütləq; APSAC, AAP protokolları.
2. Multidissiplinar qrup — pediatr, psixiatr, sosial işçi və adli mütəxəssis.
3. Ayrılma sınağı (ing. separation test) — Ana qurbandan ayrılır; simptomlar izlənir.
4. Video monitorinq — uşaq qoruma və hüquqi nəzarət altında.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- APSAC — uşaq qoruma protokolları.
- AAP — pediatr rolu.
- Hüquqi sistemin koordinasiyası mütləqdir.

9. Proqnoz

- Qurban üçün — yüksək mortalitet (6–9%) və müdaxilə olmadıqda morbidlik.
- Fail üçün — psixoterapiya ilə yaxşılaşma; uzunmüddətli izləmə.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Ana həqiqətən qayğıkeşdir, diaqnoz səhvdir»

Sübut: klinik xüsusiyyətlər (anaya bağlı simptomlar, atipik tibbi tarixçə) ciddi təsdiq tələb edir; klinik şübhə uşaq qorumaya müraciət etmək üçün kifayətdir.

Mif 2: «Bu vəziyyət psixiatrik problem deyil, sadəcə uşaq istismarıdır»

Sübut: hər iki yanaşma vacibdir — uşaq qoruma + failin psixiatrik müalicəsi.

Mif 3: «Failin müalicəsi qurbana qayğının dayandırılmasını gecikdirir»

Sübut: qurbanın təhlükəsizliyi birinci prioritet; psixiatrik müalicə ayrılıqda davam etdirilir.

Mif 4: «Yalnız anada baş verir»

Sübut: əksər hallarda ana, lakin başqa qayğı göstərənlər (atalar, digər yaxınlar, tibb işçiləri) də fail ola bilər.

Mif 5: «Konfrontasiya pasiyenti „müalicə edər“»

Sübut: konfrontasiya başqa klinikaya keçidə səbəb ola bilər; pasiyent davranışını davam etdirir; uşaq qoruma və adli koordinasiya mütləqdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D51 Başqa şəxsə qəsdən yönəldilmiş uydurma pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Medou R. Munchausen sindromu proksi vasitəsilə. Uşaq zorakılığının gizli tərəfi. «Lancet». 1977;2(8033):343–345.
4. Şeridan M.S. Aldatma davam edir: Munchausen sindromunun proksi vasitəsilə genişləndirilmiş ədəbiyyat icmalı. «Uşaq Zorakılığı və Laqeydliyi» (Child Abuse Negl). 2003;27(4):431–451.
5. Amerika Uşaq Zorakılığı üzrə Peşəkar Cəmiyyətlər Assosiasiyasının (APSAC) İşçi Qrupu. Munchausen sindromu proksi vasitəsilə: Müəyyənləşdirmə, müdaxilə və işlərin idarə edilməsi. 2018.

6D70–6D8Z NEYROKOQNİTİV POZUNTULAR

Neyrokoqnitiv pozuntular

XBT-11 **6D70**	**6D70 DELİRİUM** **Delirium**
XBT-10 F05	Alkoqol və ya digər psixoaktiv maddələr tərəfindən törədilməyən sayıqlama (delirium)
DSM-5-TR F05	Delirium

1. Tərif və nozologiya

Delirium (XBT-11: 6D70; DSM-5-TR: F05) — kəskin, dalğalanan diqqət və şüur pozulması, koqnitiv çatışmazlıq (yaddaş, oriyentasiya, dil, vizuo-məkan) və qavrayış pozuntuları (illüziya, hallüsinasiyalar) ilə xarakterizə olunan neyropsixiatrik sindrom. Tipik bir tibbi səbəbə (infeksiya, dərman, metabolik, neyroloji) cavab olaraq inkişaf edir.

Tibbi təcili haldır — mortalitet hospitalizə edilmiş yaşlı pasiyentlərdə 25–33 %.

2. Tarixçə

- Hippokrat «frenit» (yun. phrenitis) — deliriumun klassik təsviri.
- Lipowski Z.J. (1980–90-cı illər) — müasir konseptualizasiya.
- CAM (ing. Confusion Assessment Method, Inouye S.K. 1990) — qızıl standart skrininq.

3. Epidemiologiya

- Hospitalizə edilmiş yaşlılarda yayılma 15–30%; reanimasiya şöbəsində 50–80 %; cərrahi müdaxilədən sonra 15–50 %.
- Komorbidlik: demensiya (onun fonunda inkişaf edən delirium), infeksiya, polifarmasiya.
- Mortalite və morbidlik yüksək; uzunmüddətli koqnitiv enmə riski.

4. Etiologiya və patogenez

- Çoxsaylı amillər:
  - İnfeksiyalar — sepsis, pnevmoniya, sidik yolu infeksiyası (UTI);
  - Dərman — antikolinergik, opioid, benzodiazepin, steroidlər;
  - Maddə kəsilməsi (alkoqol, benzodiazepin);
  - Metabolik — elektrolit, qlükoza, ammonyak, uremiya;
  - Hipoksiya, hipoperfuziya;
  - Neyroloji — tutma, insult, beyin şişi, ensefalit;
  - Ağrı, konstipasiya, sidik tutulması;
  - Mühit — hissi məhrumiyyət, yuxu pozulması (xüsusilə ICU).

5. Klinik təzahürlər

Üç motor alt tipi

- Hiperaktiv — agitasiya, hallüsinasiya — diaqnozu asan;
- Hipoaktiv — letarji, geri çəkilmə — diaqnozu çox vaxt qoyulmur, depressiyaya bənzəyir;
- Qarışıq — fluktuasiya.

Klinik əlamətlər

- Kəskin başlanğıc (saatlar–günlər) və dalğalanma.
- Diqqət pozulması.
- Koqnitiv çatışmazlıq — yaddaş, oriyentasiya (vaxt, yer, şəxs).
- Qavrayış pozuntuları — vizual hallüsinasiyalar tipikdir.
- Yuxu-oyanma siklinin pozulması.
- Axşam saatlarında pisləşmə (ing. sundowning).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Diqqət pozulması (yönləndirmə, saxlama, ötürmə) və şüur pozulması.

B. Pozulma qısa müddətdə (saatlar–günlər) inkişaf edir; ilkin göstəricilərdən fərqlənir; gün ərzində dalğalanma.

C. Əlavə koqnitiv pozulma (yaddaş, oriyentasiya, dil, vizuo-məkan, qavrayış).

D. Demensiya və ya başqa neyrokoqnitiv pozuntu ilə tam izah olunmur.

E. E. tarixçə, müayinə və laboratoriya göstəriciləri təsdiq edir ki, pozulma birbaşa tibbi vəziyyət, maddə intoksikasiyası/kəsilməsi və ya çoxsaylı etiologiya nəticəsidir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR / XBT-11 — eyni.
- NICE CG103 — Delirium: prevention, diagnosis and management (2010, 2019 update).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. CAM (ing. Confusion Assessment Method) — qızıl standart skrininq.
2. CAM-ICU — intensiv terapiya şöbəsi üçün.
3. Tibbi səbəb axtarışı: tam qan sayı, elektrolitlər (Na, K, Ca, Mg, P), qlükoza, qaraciyər, böyrək, TSH, B12, troponin, EKG, sidik analizi və kulturası, qan kulturası, döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası, beyin MRT/KT, EEQ (tutma şübhəsi), lumbal punksiya (ensefalit/menenjit).
4. Dərman siyahısının nəzərdən keçirilməsi — antikolinergik, opioid, benzodiazepin (Beers meyarları).
5. Toksikoloji.
6. Komorbid demensiya qiymətləndirməsi (ilkin göstəricilər).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Demensiya (6D8x)	Tədrici başlanğıc; diqqət nisbi saxlanılır.
Depressiya (psixomotor lənglәmə hipoaktiv kimi)	Affektiv simptomlar dominant; diqqət nisbətən saxlanılır.
Psixotik epizod	Diqqət saxlanılır; başlanğıc fərqli.
Non-convulsive status epilepticus	EEQ.
Wernicke ensefalopatiyası	Tiamin testi; klassik triada (oftalmoplegiya, ataksiya, konfuziya).

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- CAM, CAM-ICU.
- MMSE və ya MoCA (ilkin göstəricilər koqnitiv funksiya).

- Yuxarıdakı tibbi paneldən.
- EEQ — non-convulsive status istisnası.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG103)

1. Etioloji müalicə birinci prioritet — infeksiya, metabolik, dərman, xəstəxanaya yatırılma şəraitinin düzəldilməsi.
2. Mühitin dəyişdirilməsi — sensor (eynək, qulaq cihazı), gündüz işığı, gecə qaranlığı, sakit mühit, yaxınların yanında olması.
3. Yataq baxımı — hidratasiya, qida, sidik və defekasiya, hərəkət.
4. Antipsixotik (haloperidol 0,25–2 mq, kvetiapin, risperidon) — yalnız ağır agitasiya və ya pasiyentin özünə/başqasına təhlükə təşkil etdikdə, qısamüddətli, aşağı doza. NICE CG103 — antipsixotiklər adi qaydada tövsiyə edilmir; sübut bazası məhduddur (Burry L. Cochrane 2018).
5. Benzodiazepin — yalnız alkohol və ya benzodiazepin kəsilmə deliriumında; başqa hallarda əks göstərişdir (deliriumu gücləndirir).
6. Profilaktika (qarşısının alınması) — ABCDEF paketi (SCCM) reanimasiyada (ing. Awakening, Breathing, Coordination, Delirium monitorinq, Early mobility, Family).

8.2 Müalicə metodikaları

1. Çaşqınlıq Qiymətləndirmə Metodu (ing. CAM — Confusion Assessment Method) — İnouye S.K. — 4 əsas element: kəskin başlanğıc/dalğalanma + diqqətsizlik + dezorqanizə olunmuş təfəkkür və ya şüur dəyişikliyi.
2. CAM-ICU — reanimasiya şöbəsi üçün uyğunlaşdırılmış; ventilyatorda olan pasiyentlərdə.
3. Xəstəxana Yaşlı Həyat Proqramı (ing. Hospital Elder Life Program, HELP) — İnouye (Inouye S.K.) — Çoxkomponentli delirium profilaktikası proqramı; sübut bazası güclü.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG103 — etioloji və mühit yanaşma birinci sıra; antipsixotik məhdud.
- SCCM PADIS Guidelines (ICU üçün, 2018).
- Burry L. Cochrane 2018 — antipsixotiklər deliriumun müddətini və ya mortalitetini azaltmır.

9. Proqnoz

- Hospital mortaliteti 25–33%.
- Sağ qalanlarda — funksional enmə, uzunmüddətli koqnitiv pozulma, demensiya riski artmışdır.
- Erkən etioloji müdaxilə proqnozu yaxşılaşdırır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Delirium „yaşlı insan üçün normaldır“»

Sübut: delirium klinik təcili haldır, mortalitet yüksəkdir; aktiv müdaxilə tələb edir.

Mif 2: «Antipsixotik delirium müalicəsidir»

Sübut: NICE CG103, Burry Cochrane 2018 — antipsixotiklər deliriumun müddətini və mortalitetini azaltmır; yalnız ağır agitasiya üçün.

Mif 3: «Benzodiazepin yaşlı agitasiyalı pasiyent üçün təhlükəsizdir»

Sübut: benzodiazepin deliriumu gücləndirir; yalnız alkoqol/benzodiazepin kəsilməsi halında.

Mif 4: «Hipoaktiv delirium „yaxşıdır“, müdaxilə tələb etmir»

Sübut: hipoaktiv delirium daha yüksək mortalitet ilə əlaqəlidir; diaqnozu isə çox vaxt qoyulmur.

Mif 5: «Pasiyentin yatması delirium üçün ən yaxşıdır»

Sübut: gündüz aktivlik, yaxınların yanında olması, hissi stimullaşdırma tövsiyə edilir; HELP proqramı sübuta əsaslanır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D70 Delirium. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) CG103. Delirium: profilaktika, diaqnostika və idarəetmə. 2010, 2019-cu il yenilənməsi.

4. İnouye S.K. və b. Qarışıqlığın aydınlaşdırılması: qarışıqlığın qiymətləndirilməsi metodu. «Daxili Təbabət Salnamələri» (Ann Intern Med). 1990;113(12):941–948.
5. Burri L. və b. Xəstəxanada olan qeyri-intensiv terapiya şöbəsinin xəstələrində deliriumun müalicəsi üçün antipsixotiklər. «Koçran Sistematik İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2018; (6):CD005594.
6. Devlin C.V. və b. SCCM PADIS təlimatları. «Tənqidi Qayğı Təbabəti» (Crit Care Med). 2018;46(9):e825–e873.

XBT-11 **6D71**	**6D71 YÜNGÜL NEYROKOQNİTİV POZUNTU** **Mild neurocognitive disorder**
XBT-10 F06.7	Yüngül koqnitiv pozuntu
DSM-5-TR G31.84	Yüngül neyrokoqnitiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Yüngül Neyrokoqnitiv Pozuntu (ing. XBT-11: 6D71 Mild Neurocognitive Disorder; DSM-5-TR: G31.84) — bir və ya bir neçə koqnitiv sahə (yaddaş, kompleks diqqət, icra funksiyası, dil, vizuo-məkan, sosial koqnisiya) yüngül enmə; gündəlik fəaliyyət saxlanılır (kompensasiya tələb olunsa da). Tipik adı — «yüngül koqnitiv pozulma» (ing. Mild Cognitive Impairment, MCI).

2. Tarixçə

- Petersen R.C. (1999) — MCI klinik konseptualizasiyası.
- DSM-5 (2013) — Böyük (major) və yüngül neyrokoqnitiv pozuntu kateqoriyaları.
- AAN (2018) — Practice Guideline for MCI (Petersen).

3. Epidemiologiya

- 65 yaşdan yuxarı şəxslərdə yayılma 10–20 %.

- İllik 10–15 % yüngül koqnitiv pozuntu (YKP) Alzheimer demensiyasına keçir.
- Risk amilləri: yaş, ApoE4 daşıyıcılığı, kardiovaskulyar xəstəliklər.

4. Etiologiya və patogenez

- Alzheimer xəstəliyinin prodromal mərhələsi (amnestik YKP);
- Vaskulyar;
- Levi cisimcikləri demensiyasının prodromal mərhələsi;
- Frontotemporal;
- Tibbi (depressiya, tiroid, B12, dərman təsirləri).

5. Klinik təzahürlər

- Pasiyent və ya yaxın şəxs koqnitiv enmədən şikayət edir.
- Standartlaşdırılmış testlərdə yüngül çatışmazlıq (tipik olaraq standart kənaraçıxmadan −1 ilə −2 arasında).
- Gündəlik fəaliyyət saxlanılır (kompleks fəaliyyətlərdə minimal kompensasiya).
- Alt-tiplər: amnestik (yaddaş üstünlük təşkil edir — Alzheimer riski yüksəkdir), qeyri-amnestik (icra və ya başqa sahə).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Bir və ya bir neçə koqnitiv sahə yüngül enmə (pasiyentin özü, məlumat verən şəxs və ya həkim tərəfindən qeyd və standartlaşdırılmış neyropsixoloji test).

B. Gündəlik fəaliyyət saxlanılır.

C. Delirium ilə daha yaxşı izah olunmur.

D. Başqa psixi pozuntu (TDP) ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — böyük və yüngül neyrokoqnitiv pozuntuların ayrılması.
- AAN 2018 — etioloji axtarış (Alzheimer, vaskulyar) və bioloji markerlər hələ inkişaf mərhələsindədir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və məlumat verən şəxs.
2. MoCA (ing. Montreal Cognitive Assessment) və MMSE (ing. Mini-Mental State Examination)
3. Neyropsixoloji test.
4. Laboratoriya — B12 vitamini, folat, tiroid stimullaşdırıcı hormon (TSH), qaraciyər, böyrək, qlükoza, HIV/sifilis.
5. Beyin MRT — vaskulyar, atrofiya, başqa patologiya.
6. Biomarkerlər (klinik şübhədə) — beyin-omurilik mayesində (CSF) amiloid-β/tau, PET görüntüləmə (Alzheimer prodromu).
7. Depressiya skrininqi (Geriatrik Depressiya Şkalası — GDS; PHQ-9).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Demensiya (ing. Major NCD)	Gündəlik fəaliyyət əhəmiyyətli pozulmuş.
Normal yaşa-əlaqəli koqnitiv dəyişiklik	Test edilərkən normal performans.
Depressiya (psevdodemensiya)	Affektiv simptomlar üstünlük təşkil edir; antidepressantlarla yaxşılaşma müşahidə olunur.
Delirium (6D70)	Kəskin başlanğıc, diqqət dalğalanması.
B12 və ya tiroid çatışmazlığı	Laboratoriya göstəriciləri; düzəldilmə ilə yaxşılaşma.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- MoCA (≤ 25 patoloji) — MCI (yüngül koqnitiv pozuntu) üçün etibarlılığı təsdiqlənmiş skrininq; MMSE (qısa psixi status şkalası) üçün MCI (yüngül koqnitiv pozuntu) həddi müəyyən edilməmişdir və yüngül pozuntuya həssaslığı aşağıdır.
- Neyropsixoloji test batareyası (yaddaş, icra, dil, vizuo-məkan).
- Laboratoriya paneli.
- MRT (rutin), bioloji markerlər (seçici).

8. Müalicə

1. Etioloji müalicə — modifikasiya edilə bilən amillər (kardiovaskulyar risk, B12, tiroid, depressiya, dərman).
2. Həyat tərzi — fiziki aktivlik (aerobik), Aralıq dənizi pəhrizi, koqnitiv stimullaşdırma, sosial əlaqələr (FINGER tədqiqatı (Lancet, 2015;385(9984):2255–2263) — çoxmodallı yanaşma təsirli olmuşdur).
3. Farmakoterapiyanın MCI üçün xüsusi təsdiqi yoxdur. Donepezil və başqa AChEI — sübut bazası məhduddur; rutin tövsiyə edilmir.
4. Lekanemab, donanemab — yeni anti-amyloid antikorlar; ABŞ Qida və Dərman Administrasiyasının (FDA) təsdiqi (lekanemab 2023, donanemab 2024) Alzheimer xəstəliyinin prodrom mərhələsi və yüngül demensiya üçün; klinik effekti mülayimdir, infuziya reaksiyaları və amiloidlə əlaqəli görüntüləmə anomaliyaları (ing. ARIA — Amyloid-Related Imaging Abnormalities) riskli.
5. Komorbid depressiya və narahatlığın müalicəsi (seçici serotonin geri alım inhibitorları — SSGİ).
6. Demensiyaya keçid riskinin izlənməsi.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Monreal Koqnitiv Qiymətləndirmə (ing. MoCA — Montreal Cognitive Assessment) — Nəsrəddin (Nasreddine Z.S.) — maksimum 30 bal (11 tapşırıq); MCI skrininq (həd balı 26).
2. FINGER Çoxmodallı Müdaxiləsi (ing. FINGER — Finnish Geriatric Intervention Study) — Pəhriz, fiziki aktivlik, koqnitiv təlim və vaskulyar riskin idarə edilməsi.
3. Lekanemab, donanemab — anti-amiloid antikorlar; FDA təsdiqi; ARIA-nın MRT ilə izlənməsi.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AAN 2018 — modifikasiya edilə bilən amillər və həyat tərzi.
- FINGER trial (Ngandu Lancet 2015) — çoxmodallı müdaxilə.
- Lekanemab — CLARITY-AD (van Dyck NEJM 2023); donanemab — TRAILBLAZER-ALZ 2 (Sims JAMA 2023).

9. Proqnoz

- Pasiyentlərin 30%-i stabil qalır, ildə 10–15%-də demensiya inkişaf edir, 15–20%-i normaya qayıdır.

- Amnestik MCI (yüngül koqnitiv pozuntu) Alzheimer xəstəliyinin prodromudur — yüksək keçid riski.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «MCI mütləq demensiyaya çevrilir»

Sübut: illik 10–15% keçir; bir hissə stabil qalır və ya yaxşılaşır.

Mif 2: «Vitamin B və ginkgo MCI-ni sağaldır»

Sübut: B vitaminləri yalnız çatışmazlıqda; Ginkgo biloba (Cochrane, Birks 2009) — təsiri zəif sübut edilmişdir.

Mif 3: «AChEI standart MCI müalicəsidir»

Sübut: AAN 2018 — sübut bazası kifayət deyil; rutin tövsiyə edilmir.

Mif 4: «Lekanemab MCI/Alzheimer-i sağaldır»

Sübut: koqnitiv enmənin tempini təxminən 25% azaldır; ARIA və infuzion reaksiyalar; «sağaltma» deyil.

Mif 5: «Koqnitiv enmə yaşla qaçınılmazdır»

Sübut: kardiovaskulyar risk, fiziki aktivlik, sosial əlaqələr modifikasiya edilə bilən amillərdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D71 Yüngül nevrokoqnitiv pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Petersen R.C. və b. Təcrübə təlimatının yenilənməsinin xülasəsi: Yüngül koqnitiv pozuntu. «Nevrologiya» (Neurology). 2018;90(3):126–135.
4. Nqandu T. və b. Pəhriz, idman, koqnitiv təlim və damar risk faktorlarının monitorinqindən ibarət 2 illik çoxsahəli müdaxilə (FINGER): randomizə edilmiş nəzarətli sınaq. «Lancet». 2015;385(9984):2255–2263.
5. van Dayk C.H. və b. Altsheymer xəstəliyinin erkən mərhələsində lekanemab. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2023;388(1):9–21.
6. Nasreddin Z.S., Fillipps N.A., Bədiryan V. və b. Monreal Koqnitiv Qiymətləndirmə, MoCA: yüngül koqnitiv pozuntu üçün qısa skrininq aləti.

«Amerika Geriatriya Cəmiyyətinin Jurnalı» (J Am Geriatr Soc). 2005;53(4):695–699.

7. Birks C., Qrimli Evans C. Koqnitiv pozuntu və demensiya üçün Ginkgo biloba. «Koçran Sistematik İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2009;(1):CD003120.

XBT-11 **6D72**	**6D72 AMNESTİK POZUNTU** **Amnestic disorder**
XBT-10 F04	Alkoqol və ya digər psixoaktiv maddələr tərəfindən törədilməyən üzvi amnestik sindrom
DSM-5-TR F02.8x	Başqa tibbi vəziyyətə görə ağır neyrokoqnitiv pozuntu (amnestik forma)

1. Tərif və nozologiya

Amnestik Pozuntu (XBT-11: 6D72 Amnestic Disorder; DSM-5-TR: F04 və oxşar) — yeni məlumatın öyrənilməsi və geri çağırılmasının əhəmiyyətli pozulması; başqa koqnitiv sahə nisbi saxlanılır. Tibbi vəziyyət (Wernicke-Korsakoff, beyin zədəsi, ensefalit, anoksiya), Maddənin təsiri və ya başqa səbəblə əlaqədar ola bilər.

2. Tarixçə

- Korsakoff S. (1887) — alkoholla əlaqəli amneziyanın təsviri.
- Scoville W.B., Milner B. (1957) — H.M. hadisəsi (ikitərəfli medial temporal sahənin rezeksiyasından sonra amneziya).

3. Epidemiologiya

- Korsakoff sindromu — xroniki ağır alkohol istifadə edənlərin 12–25%-ində.
- Travmatik beyin zədəsindən sonra amneziya — TBZ (travmatik beyin zədəsi) pasiyentlərinin 30–50%-ində.
- Keçici qlobal amneziya (TGA — transient global amnesia) 65 yaşdan yuxarı şəxslərdə 100 000 nəfərə ildə 5–25 hal tezliyi ilə müşahidə olunur.

4. Etiologiya və patogenez

- Wernicke-Korsakoff — tiamin (B1) çatışmazlığı (alkohol, malnutrisiya).

- Travmatik beyin zədəsi (TBİ).
- Hipoksiya/anoksiya — kardial arest, karbon monoksid.
- Herpes simpleks ensefaliti.
- Autoimmun ensefalit (anti-NMDA, anti-LGI1).
- Keçici qlobal amneziya (TGA) — vaskulyar səbəb şübhəsi.
- Maddə (alkohol blackout, benzodiazepin).
- İnsult (xüsusilə bilateral talamik və ya hipokampal).

5. Klinik təzahürlər

- Anterograd amneziya — yeni informasiyanın öyrənmə pozulması (əsas xüsusiyyət).
- Retrograd amneziya — zədədən əvvəlki dövrün yaddaşı («Ribo qanunu» — ən yeni xatirələr ilk növbədə itirilir, ən köhnələri isə daha uzun saxlanılır).
- Konfabulyasiya Korsakoff sindromunda müşahidə olunur: pasiyent boş yaddaş yerlərini uydurmalarla doldurur.
- Başqa koqnitiv sahə nisbi saxlanılır (intellekt, dil, vizual-məkan).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Yeni informasiyanın öyrənmə pozulması və ya əvvəllər öyrənilmiş məlumatın geri çağırılmasının pozuntusu.

B. Yaddaş pozuntusu əhəmiyyətli funksional pozulma yaradır.

C. Yalnız delirium və ya başqa neyrokoqnitiv pozuntu (NKP) kontekstində baş vermir.

D. Sübut — tarixçə, müayinə və laboratoriya məlumatları göstərir ki, yaddaş pozulması xüsusi səbəblə (tibbi vəziyyət, maddə) əlaqədardır.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR — ağır və yüngül neyrokoqnitiv pozuntu strukturuna inteqrasiya; amnestik alt tip.
- XBT-11-də amnestik pozuntu ayrı kateqoriya kimi verilmişdir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və yaxınlarının verdiyi məlumatlar (informant).

2. Neyropsixoloji test — yaddaş (WMS-IV, RAVLT, Wechsler Logical Memory).
3. Beyin MRT — ikitərəfli hipokampal, medial temporal və talamik patologiya.
4. Tiamin (B1) səviyyəsi və ya empirik tiamin (Korsakoff şübhəsi).
5. Toksikoloji.
6. Autoimmun ensefalit panel (atipik halda).
7. Elektroensefaloqrafiya (EEQ).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Alzheimer demensiyası	Çoxsaylı koqnitiv sahə, tədrici başlanğıc.
Delirium (6D70)	Diqqət dalğalanması.
Dissosiativ amneziya (6B61)	Travma kontekstində; selektiv keçmiş yaddaş; tibbi səbəb yoxdur.
süni pozuntu (faktisioz) / simulyasiya	Atipik klinik gediş, ikincili qazanc.
TGA	Kəskin, 24 saatdan az; tam bərpa.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- WMS-IV (ing. Wechsler Memory Scale), RAVLT.
- Beyin MRT.
- Tiamin, B12.
- Toksikoloji.

8. Müalicə

1. Etioloji — tiamin (Wernicke-Korsakoff — 500 mq venadaxili (v/d) gündə 3 dəfə, 3 gün ərzində × 3 gün, sonra 250 mq IM/gündə × 3–5 gün; alkoholdan imtinada uzunmüddətli ağızdan tiamin qəbulu).
2. Autoimmun ensefalit — immunoterapiya (steroidlər, venadaxili immunoqlobulin — IVIG, plazmaferez, rituksimab).
3. Herpes ensefalit — asiklovir.
4. Kompensasiyaedici strategiyalar (xarici yaddaş yardımları, gündəlik strukturlaşdırma).

5. Maddə istifadəsi pozuntusunun (alkohol) müalicəsi.
6. Koqnitiv reabilitasiya (Vilson B.A.).

8.1 Müalicə metodikaları

1. Wernicke-Korsakoff Profilaktikası və Müalicəsi — Tiamin IV/IM yüksək dozada; qlükozadan əvvəl yeridilməsi həlledicidir (qlükoza tiamin çatışmazlığında Wernicke ensefalopatiyasını ağırlaşdırır).
2. Koqnitiv Reabilitasiya (ing. Cognitive Rehabilitation) — Vilson (Wilson B.A.) — Xarici yaddaş yardımları (jurnal, telefon xatırladıcıları), strategiya öyrətmə.
3. İmmunoterapiya (autoimmun ensefalit) — Graus F. və b. (2016) protokolu.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Wernicke-Korsakoff — Kral Həkimlər Kollecinin tiamin protokolu (ing. Royal College of Physicians thiamine protocol).
- Graus F. və b. Lancet Neurol 2016 — autoimmun ensefalit.

9. Proqnoz

- TGA — tam bərpa.
- Korsakoff — qalıq çatışmazlıq tipik; tiamin ilə Wernicke akut müdaxilə kritik.
- TBİ — reabilitasiya ilə qismən bərpa.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Amneziya hipnoz ilə „bərpa edilə bilər“»

Sübut: hipnoz yalançı xatirə yarada bilər; organik amneziyada isə effektsizdir.

Mif 2: «Wernicke ensefalopatiyasında oral tiamin kifayətdir»

Sübut: oral absorbsiya kifayət deyil; IV/IM yüksək doza tələb olunur.

Mif 3: «Qlükoza ilə Wernicke „sağaldır“»

Sübut: tiamin defisitində qlükoza Wernicke ensefalopatiyasını gücləndirir; ona görə əvvəlcə tiamin yeridilməlidir.

Mif 4: «Bütün amneziya keçicidir»

Sübut: Korsakoff, TBİ-əsaslı amneziya tipik xronik; reabilitasiya yaxşılaşma təmin edir, lakin tam bərpa az.

Mif 5: «Konfabulyasiya yalandır»

Sübut: konfabulyasiya Korsakoff sindromunda neyrobioloji fenomendir, şüurlu yalan deyil.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D72 Amnestik pozuntu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniya Kral Həkimlər Kolleci (RCP). Vernike ensefalopatiyası və Korsakov sindromu. 2014.
4. Qraus F. və b. Autoimmün ensefalitin diaqnostikasına klinik yanaşma. «Lancet Nevrologiyası» (Lancet Neurol). 2016;15(4):391–404.
5. Uilson B.A. Neyropsixoloji reabilitasiya. Uayli-Blekvell; 2009.

XBT-11 **6D80**	**6D80 ALZHEİMER XƏSTƏLİYİ NƏTİCƏSİNDƏ DEMENSİYA** **Dementia due to Alzheimer disease**
XBT-10 F00	Alzheimer xəstəliyi zamanı demensiya
DSM-5-TR G30.9 + F02.8x	Alzheimer xəstəliyinə görə ağır neyrokoqnitiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Alzheimer xəstəliyi nəticəsində demensiya (XBT-11: 6D80; DSM-5-TR: G30.9 + F02.8x Alzheimer xəstəliyinə görə ağır neyrokoqnitiv pozuntu (ing. Major Neurocognitive Disorder due to Alzheimer disease)) — tədrici və davamlı koqnitiv enmə, başlanğıcda epizodik yaddaş, sonra çoxsaylı koqnitiv sahə və gündəlik fəaliyyətin əhəmiyyətli dərəcədə pozulması. Demensiyaların ən geniş yayılmış səbəbidir (60–70%).

2. Tarixçə

- Alzheimer A. (1906) — ilk klinik və patohistoloji təsvir.
- Amiloid hipotezi (Hardy J., Higgins G.A. Science 1992).
- NICE NG97 (2018) — demensiya üzrə klinik təlimat
- FDA — aducanumab (2021, mübahisəli), lekanemab (2023), donanemab (2024) — anti-amyloid antikorlar.

3. Epidemiologiya

- Dünyada 55 milyondan çox demensiya pasiyenti var (ÜST, 2023); onların 60–70%-i Alzheimer xəstəliyidir.
- Yayılma yaşa görə: 65 yaş 5%, 80+ yaş 25%+.
- Cins bölgüsü: qadınlarda daha yüksəkdir (gözlənilən ömür müddəti ilə əlaqədardır).
- Komorbidlik: kardiovaskulyar, depressiya, narahatlıq, demensiyanın davranış və psixoloji simptomları (ing. behavioral and psychological symptoms of dementia, DDPS).

4. Etiologiya və patogenez

- Ailəvi Alzheimer xəstəliyi (1%): APP, PSEN1 və PSEN2 genlərində mutasiyalar (erkən başlanğıc, dominant).
- Sporadik (99%) — bir çox gen (ApoE4 ən güclü risk amili; gec başlanğıclı Alzheimer xəstəliyi üzrə GWAS lokusları).
- Modifikasiya edilə bilən amillər (Lancet Commission 2024) — yaş, ApoE4 yanında: aşağı təhsil, eşitmə itkisi, hipertenziya, piylənmə, siqaret, depressiya, fiziki passivlik, sosial təcrid, diabet, hava çirklənməsi, alkohol, TBZ, görmə itkisi, yüksək LDL.
- Patogenez — amiloid-β lövhələri + tau neyrofibrilyar düyünləri və neyroiltihablanma.

5. Klinik təzahürlər

- Tipik başlanğıc — epizodik yaddaş enməsi (yeni informasiya saxlama çətinliyi).
- Mərhələlər:
    - Erkən — yaddaş, anomiya, oriyentasiya çətinliyi;
    - Orta — vizuo-məkan, icra funksiyası, gündəlik fəaliyyətdə dəstəyə ehtiyac yaranır;

    - Gec — dil çox məhdud, yaxınlarını tanımama, hərəkət məhdudiyyəti, qidalanma və udma çətinliyi.
- BPSD — agitasiya, aqressiya, sayıqlamalar (xüsusilə oğurluq), hallüsinasiyalar, depressiya, narahatlıq, yuxu pozuntusu, gün batımı sindromu
- Atipik formalar: posterior kortikal atrofiya (vizual-məkan üstünlüyü ilə), loqopenik birincili proqressiv afaziya (dil üstünlüyü ilə).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Ağır neyrokoqnitiv pozuntu (NKP) meyarları (≥ 1 koqnitiv sahə əhəmiyyətli enmə + gündəlik fəaliyyət pozulması).

B. Klinik xarakteristikası Alzheimer xəstəliyinə uyğundur (tədrici, davamlı enmə, yaddaş əsas).

C. Probable AD — genetik mutasiya və ya 3 element (yaddaş + 1+ koqnitiv sahə, davamlı enmə, başqa səbəb yox).

D. Mümkün Alzheimer xəstəliyi (Possible AD) — meyarlara tam uyğun gəlmir, lakin atipik klinik və ya komorbidlik.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NIA-AA Research Framework (Jack C.R. 2018) — bioloji markerlərə əsaslanan diaqnoz (ATN — amiloid, tau, neyrodeqenerasiya).
- NICE NG97 — klinik diaqnostika əsaslı; biomarkerlər seçici.
- AAN — diaqnostik vasitələr.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + informant.
2. MoCA, MMSE, ACE-III.
3. Neyropsixoloji battery.
4. Laborator — B12, folat, TSH, qaraciyər, böyrək, qlükoza, HIV/sifilis (tibbi səbəb istisnası).
5. Beyin MRT (atrofiya, vaskulyar dəyişikliklər, başqa patologiya).
6. Biomarkerlər (seçici, klinik şübhədə):
    - BOS (beyin onurğa mayesi) amiloid-β42 (aşağı), tau (yüksək);
    - Amiloid PET, tau PET;

- Qan biomarkerləri (p-tau217, GFAP) — yeni inkişaf mərhələsindədir.

7. Komorbid depressiyanın skrininqi (GDS — Geriatrik Depressiya Şkalası).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Vaskulyar demensiya (6D81)	Pilləli enmə, fokal nevroloji simptomlar, vaskulyar MRT.
Levi cisimcikləri xəstəliyi nəticəsində demensiya (6D82)	Vizual hallüsinasiyalar, parkinsonizm, yuxunun REM (ing. rapid eye movement) fazasında davranış pozuntusu.
Frontotemporal (6D83)	Şəxsiyyət/davranış və ya dil dominant; daha erkən başlanğıc.
Delirium (6D70)	Kəskin, dalğalanan diqqət.
Depressiv pseudodemensiya	Affektiv, antidepresanla yaxşılaşma.
Normal təzyiqli hidrosefaliya (NPH)	Klassik triada (yeriş pozuntusu, sidik saxlaya bilməmə, koqnitiv enmə).
Tibbi (B12, tiroid, neyrosifilis, HIV)	Laborator.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- MoCA, MMSE, ACE-III, neyropsixoloji.
- Laborator panel.
- MRT, biomarkerlər.
- BPSD şkalaları (NPI — Neuropsychiatric Inventory).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE NG97, AAN, APA)

1. AChEI (donepezil, qalantamin, rivastigmin) — yüngül və orta dərəcəli Alzheimer xəstəliyi üçün; koqnitiv enməni mülayim dərəcədə yavaşladır. Donepezil 5–10 mq (sonra 23 mq), rivastigmin patch.
2. Memantin (NMDA antaqonisti) — orta-ağır Alzheimer üçün; AChEI ilə birlikdə istifadə edilir.

3. Anti-amyloid antikorlar (lekanemab, donanemab) — erkən simptomatik Alzheimer xəstəliyi (AX) üçün FDA təsdiqi (lekanemab 2023, donanemab 2024); koqnitiv enmənin tempini təxminən 25% azaldır; ARIA (Amyloid-Related Imaging Abnormalities — ödem, mikroqanaxma) riski yüksək (xüsusilə ApoE4 homozigotlarda); MRT ilə izləmə vacibdir; preparat venadaxili infuziya şəklində verilir. Klinik fayda mübahisəlidir.
4. BPSD idarəsi:
    - Birinci xətt — qeyri-farmakoloji yanaşmalar (mühit, sosial dəstək, fiziki aktivlik, musiqi terapiyası);
    - Refrakter halda — atipik antipsixotik (risperidon, kvetiapin) aşağı dozada, qısamüddətli; FDA BLACK BOX — yaşlı demensiya xəstələrində antipsixotiklər ölüm riskini (insult, kardiovaskulyar hadisələr) artırır.
    - SSGİ — komorbid depressiya və narahatlıq üçün;
    - Trazodon — yuxu pozulması;
    - Benzodiazepin — əks-göstərişdir (yıxılma, koqnitiv pisləşmə).
5. Qulluqçunun dəstəklənməsi və psixoedukasiya müalicənin vacib komponentidir.
6. həyat tərzi — fiziki aktivlik, koqnitiv stimullaşdırma, sosial əlaqələr.
7. Əvvəlcədən verilmiş göstərişlər (ing. advance directives) — qulluq və qərar qəbulunun planlaşdırılması.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Asetilkolinesteraza inhibitorları (AChEI — Acetylcholinesterase Inhibitors) — Donepezil, Qalantamin, Rivastigmin — Asetilkolinesterazanı inhibə edir; sinaptik asetilkolinin miqdarı artır (NICE NG97).
2. Memantin — NMDA antaqonisti; ekssitotoksiklik azaldır.
3. Lekanemab, Donanemab — Anti-amyloid monoklonal antikorlar; erkən AD üçün; ARIA monitorinqi.
4. BPSD üçün Qeyri-Farmakoloji — etibarlılıq yoxlanışı (validasiya) terapiyası, musiqi terapiyası, xatirələrin canlandırılması terapiyası, ABC analizi.
5. FINGER çoxmodallı müdaxiləsi profilaktika məqsədilə istifadə olunur.
6. Qulluqçu Dəstəyi (ing. Carer Support) — psixoedukasiya, fasiləli qulluq (respite), hüquqi-maliyyə planlaşdırılması.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG97 (2018) — AChEI yüngül və orta dərəcəli, memantin orta və ağır dərəcəli Alzheimer xəstəliyində təyin edilir; kombinasiya seçilmiş hallarda istifadə olunur.
- Livingston G. və b. Lancet Commission 2024 — 14 modifikasiya edilə bilən risk amili.
- FDA 2023-cü ildə lekanemabı, 2024-cü ildə donanemabı erkən Alzheimer xəstəliyi üçün təsdiqləmişdir; ARIA izlənilməlidir.
- APA (Amerika Psixiatriya Assosiasiyası) yaşlılarda antipsixotiklərin istifadəsi üzrə qaydalar müəyyən etmişdir.

9. Proqnoz

- Diaqnozdan sonra orta gözlənilən ömür 8–10 il.
- Gedişin sürəti ailə tarixçəsi və ApoE4 statusundan asılı olaraq dəyişir.
- Komorbid kardiovaskulyar xəstəliklər ölüm riskini artırır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Alzheimer normal yaşlanmadır»

Sübut: Alzheimer xəstəlikdir; normal yaşlanma koqnitiv enməsiz keçə bilər; demensiya hallarının 45%-ə qədəri modifikasiya edilə bilən amillərlə bağlıdır (Lancet Commission 2024).

Mif 2: «Demensiya qaçınılmazdır, profilaktika mümkün deyil»

Sübut: Lancet Commission 2024 — modifikasiya edilə bilən amillərin idarə edilməsi potensial demensiya potensial olaraq demensiya hallarının 45%-ə qədərini gecikdirə bilər.

Mif 3: «Lekanemab Alzheimer-i sağaldır»

Sübut: koqnitiv enmənin tempini təxminən 25% azaldır (mülayim effekt); ARIA və infuzion riskləri əhəmiyyətlidir; «sağaltma» deyil.

Mif 4: «Antipsixotik yaşlı demensiya pasiyentlər üçün təhlükəsizdir»

Sübut: FDA black box — antipsixotik yaşlı demensiya pasiyentlərdə mortalitet artırır (insult, kardiovaskulyar); yalnız ağır agitasiya/psixoz üçün, qısamüddətli.

Mif 5: «Ginkgo biloba demensiya profilaktikasıdır»

Sübut: Cochrane (Birks J. 2009) — ginkgo demensiya üçün sübutlu effekt göstərmir.

Mif 6: «Kokos yağı (coconut oil) Alzheimer xəstəliyini sağaldır»

Sübut: klinik təsdiq yoxdur; populyar mətbuatda təbliğ edilir, klinik tövsiyə deyil.

Mif 7: «Pasiyentə demensiya diaqnozunu söyləmək lazım deyil»

Sübut: NICE — pasiyentin diaqnozu bilmək hüququ var; erkən qərar qəbulu və əvvəlcədən verilmiş göstərişlər vacibdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D80 Altsheymer xəstəliyi nəticəsində demensiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Ruhi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE) NG97. Demensiya: qiymətləndirmə, idarəetmə və dəstək. 2018.
4. Livinqston Q. və b. Demensiyanın profilaktikası, müdaxilə və qayğı: «Lancet» daimi Komissiyasının 2024-cü il hesabatı. «Lancet». 2024;404(10452):572–628.
5. Cek K.R. və b. NIA-AA Tədqiqat Çərçivəsi: Altsheymer xəstəliyinin bioloji tərifinə doğru. «Altsheymer və Demensiya» (Alzheimer's Dement). 2018;14(4):535–562.
6. van Dayk C.H. və b. Erkən Altsheymer xəstəliyində lekanemab. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2023;388(1):9–21.
7. Sims C.R. və b. Erkən simptomatik Altsheymer xəstəliyində donanemab (TRAILBLAZER-ALZ 2). «JAMA». 2023;330(6):512–527.
8. ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA). «Qara qutu» xəbərdarlığı: demensiyası olan yaşlılarda antipsixotiklər. 2005.
9. Birks C. Koqnitiv pozulma və demensiyada Ginkgo biloba. «Cochrane Sistematik İcmallar Məlumat Bazası» (Cochrane Database Syst Rev). 2009; (1):CD003120.

XBT-11 **6D81**	**6D81 SEREBROVASKULYAR XƏSTƏLİK NƏTİCƏSİNDƏ DEMENSİYA** **Dementia due to cerebrovascular disease**
XBT-10 F01	Vaskulyar demensiya
DSM-5-TR F01.5x	Ağır vaskulyar neyrokoqnitiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Serebrovaskulyar xəstəlik nəticəsində demensiya (serebrovaskulyar demensiya) (XBT-11: 6D81; DSM-5-TR: F01.5x) — beyin damar xəstəliyi (insult, kiçik damar xəstəliyi, hipoperfuziya) nəticəsində inkişaf edən koqnitiv enmə və gündəlik fəaliyyət pozulması. Demensiya səbəbləri arasında ikinci yerdir (təxminən 15–20%).

2. Tarixçə

- Binswanger O. (1894) — subkortikal vaskulyar demensiyanın klassik təsviri.
- NINDS-AIREN (1993) — beynəlxalq diaqnostik meyarlar qəbul edilmişdir.
- VASCOG (Vaskulyar Koqnitiv Pozuntular üzrə Beynəlxalq Cəmiyyət) 2014 — yenilənmiş konsensus.

3. Epidemiologiya

- Demensiya hallarının 15–20%-i; bir çox halda Alzheimer xəstəliyi ilə qarışıq formada rast gəlinir.
- Yaşa görə yayılma artır.
- Risk amilləri: hipertenziya, diabet, hiperlipidemiya, atrial fibrilyasiya, siqaret, insult tarixçəsi.

4. Etiologiya və patogenez

- İri damar insult (çoxinfarktlı demensiya).
- Kiçik damar xəstəliyi (subkortikal leykoarayoz, lakunar infarktlar — Binswanger).
- Strategik infarkt (talamik, hippokampal).
- Hipoperfuziya (sistemik hipotenziya, kardial arest).
- CADASIL (otosomal dominant subkortikal demensiya, NOTCH3 geni).

5. Klinik təzahürlər

- «Pilləli» enmə (Alzheimer xəstəliyinin tədrici enməsindən fərqli olaraq).
- İcra funksiyası, emal sürəti, diqqət dominant — yaddaş nisbətən az pozulur (Alzheimer xəstəliyindən fərqi).
- Fokus neyroloji əlamətlər — hemiparezi, dizartriya, ekstrapiramidal simptomlar, vizual sahə defekti.
- Əhval pozuntuları (vaskulyar depressiya), apatiya və abuliya tez-tez müşahidə olunur.
- Postural pozuntular (yeriş, tarazlıq).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (NINDS-AIREN, VASCOG)

A. Ağır neyrokoqnitiv pozuntu (NKP) meyarlarına uyğun gəlmə.

B. Klinik xüsusiyyətlər vaskulyar etiologiyaya uyğun: ya (1) pilləli enmə və insult tarixçəsi, ya da (2) icra funksiyası və emal sürətinin üstünlük təşkil etməsi.

C. Beyin görüntüləməsində vaskulyar patologiya sübutu — infarktlar, leykoaraiozis, mikroqanaxma.

D. Koqnitiv enmə ilə vaskulyar hadisə arasında zaman bağlılığı (ing. Probable VaD).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- VASCOG 2014 (Sachdev P. və b. Alzheimer Dis Assoc Disord) — «Vascular Cognitive Impairment» ümumi anlayış kimi təqdim edilmişdir.
- NICE NG97 — vaskulyar risk amillərinin idarə edilməsi.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + informant.
2. MoCA (icra funksiyası altşkalalarına diqqət).
3. Neyroloji müayinə — fokus əlamətlər.
4. Beyin MRT (FLAIR (maye attenasiyalı inversiya bərpası) — leykoarayoz, DWI (diffuziya çəkili görüntüləmə) — kəskin infarktlar, T2/SWI — mikroqanaxma).
5. Kardiovaskulyar qiymətləndirmə — qan təzyiqi, EKG (atrial fibrilyasiya), Holter, karotid USG, exo.
6. Laboratoriya — HbA1c, lipid profili, koaqulyasiya göstəriciləri, homosistein səviyyəsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Alzheimer (6D80)	Tədrici, yaddaş dominant.
Qarışıq demensiya (Alzheimer + VaD)	Bir çox halda rast gəlinir; klinik mənzərə qarışıqdır.
Lewy cisimcikləri (6D82)	Vizual hallüsinasiyalar, parkinsonizm.
Frontotemporal (6D83)	Şəxsiyyət/davranış dominant.
Normal təzyiqli hidrosefaliya	Triada (yeriş pozuntusu, sidik saxlaya bilməmə, koqnitiv enmə).
Depressiv pseudodemensiya	Affektiv, antidepressant ilə yaxşılaşma.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- MoCA, neyropsixoloji.
- MRT, kardiovaskulyar.
- Laborator panel.

8. Müalicə

1. Vaskulyar risk amillərinin idarə edilməsi — birinci xətt:
    - Hipertenziya (hədəf sistolik qan təzyiqi 140 mm Hg-dən, bəzən 130 mm Hg-dən aşağı);
    - Diabetdə HbA1c səviyyəsinin idarə edilməsi;

- Statin (lipid);
- Trombosit əleyhinə vasitələr (aspirin) və ya antikoaqulyantlar (atrial fibrilyasiyada — birbaşa təsir edən ağızdan antikoaqulyantlar, DOAC);
- Siqaretdən imtina;
- Fiziki aktivlik, pəhriz.

2. AChEI və memantin — vaskulyar demensiya üçün sübut bazası məhduddur, lakin qarışıq demensiyada təsirli ola bilər; NICE NG97 — qarışıq halda nəzərdən keçirilir.
3. BPSD idarəsi — qeyri-farmakoloji üsullar birinci sırada dayanır; antipsixotik məhdud (Alzheimer üçün eyni FDA black box).
4. Depressiya (vaskulyar depressiya) — seçici serotonin geri alım inhibitorları (SSGİ).
5. İnsultdan sonrakı reabilitasiya — fizioterapiya, məşğuliyyət terapiyası, nitq terapiyası.

8.1 Müalicə metodları

1. Vaskulyar risk amillərinin idarə edilməsi — hipertenziya, diabet, dislipidemiya, qulaqcıq fibrilyasiyası, siqaret çəkmə
2. Asetilxolinesteraza inhibitorları (AXEI)/memantin qarışıq demensiyada — Donepezil, rivastigmin off-label saf VaD-da; qarışıq halda nəzərdə tutula bilər.
3. İnsultdan sonrakı reabilitasiya multidissiplinar xarakter daşıyır.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG97 — vaskulyar risk idarəsi.
- AHA/ASA stroke profilaktikası.

9. Proqnoz

- Risk amillərinin idarə edilməsi koqnitiv enmə sürətini azaldır.
- İnsult tarixçəsi və komorbidlik proqnozu müəyyənləşdirir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «VaD Alzheimer-dən tamamilə fərqlidir»

Sübut: əksər demensiya hallarında qarışıq patologiya (Alzheimer + VaD); klinik fərqləndirmə bəzən çətindir.

Mif 2: «VaD üçün spesifik müalicə yoxdur»

Sübut: vaskulyar risk amillərinin idarə edilməsi — birinci sıra və ən təsirli müdaxilədir; profilaktika xüsusilə güclüdür.

Mif 3: «Aspirin demensiya profilaktikası üçün»

Sübut: ASPREE trial (McNeil J.J. NEJM 2018) — ilkin profilaktikada aspirin demensiyanın qarşısını aldığını təsdiqləməyib; yalnız insult profilaktikası üçün xüsusi göstərişlər olduqda təyin edilir.

Mif 4: «Vitaminlər və homosistein vaskulyar demensiyanın profilaktikası üsulu deyil»

Sübut: homosisteini azaldan vitaminlərin koqnitiv profilaktikası sübut zəif.

Mif 5: «Stepwise enmə VaD diaqnozu üçün məcburidir»

Sübut: kiçik damar demensiyasında tədrici enmə tipikdir; yalnız multiinfarkt formada.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D81 Damar demensiyası. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG97 nömrəli təlimat. 2018.
4. Saçdev P. və b. Damar koqnitiv pozuntuları üçün diaqnostik meyarlar: VASCOG bəyanatı. «Altsheymer xəstəliyi və əlaqəli pozuntular» (Alzheimer Dis Assoc Disord). 2014;28(3):206–218.
5. MakNil C.C. və b. Sağlam yaşlılarda aspirinın əlillik olmadan sağ qalma müddətinə təsiri (ASPREE). «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (NEJM). 2018;379(16):1499–1508.
6. Livinqston Q. və b. «Lancet» Komissiyasının 2024-cü il məruzəsi. «Lancet». 2024.

XBT-11 **6D82**	**6D82 LEWY CİSİMCİKLƏRİ XƏSTƏLİYİ NƏTİCƏSİNDƏ DEMENSİYA** **Dementia due to Lewy body disease**
XBT-10 F02.8	Başqa rubrikalarda təsnif edilən, digər dəqiqləşdirilmiş xəstəliklər zamanı demensiya
DSM-5-TR G31.83 + F02.8x	Lewy cisimcikləri ilə ağır və ya yüngül neyrokoqnitiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Lewy cisimcikləri xəstəliyi nəticəsində demensiya (Lewy cisimcikləri demensiyası, DLB; XBT-11: 6D82; DSM-5-TR: G31.83 + F02.8x) α-sinuklein patologiyasının törətdiyi neyrokoqnitiv pozuntu; klassik təsvirdə üçlük — koqnitiv fluktuasiya, vizual hallüsinasiyalar, parkinsonizm; McKeith 2017 meyarlarında əsas klinik xüsusiyyətlər dörddür (REM yuxu davranış pozuntusu əlavə olunub). Demensiyaların 5–15%-i.

Parkinson xəstəliyi demensiyası (PDD) — eyni patologiya, lakin demensiya parkinsonizmdən ən azı 1 il sonra inkişaf edir; DLB və PDD eyni klinik spektrin hissəsidir.

2. Tarixçə

- Lewy F. (1912) — Parkinson xəstəliyində Lewy cisimciklərinin təsviri.
- McKeith I. (1996; 2017-ci il yenilənməsi) — DLB konsensus meyarları.

3. Epidemiologiya

- Demensiya hallarının 5–15%-i; kişilərdə yayılma qadınlara nisbətən yüksəkdir.
- 65 yaşdan sonra yayılma sürəti artır.
- Komorbidlik: depressiya, sanrılar. REM yuxu davranış pozuntusu isə əsas klinik xüsusiyyətdir.

4. Etiologiya və patogenez

- α-Sinüklein aqreqasiyası — Lewy cisimcikləri kortikal və substantia nigra-da.
- SNCA, LRRK2 və GBA genlərindəki mutasiyalar risk amilləridir.

5. Klinik təzahürlər

Dörd əsas klinik xüsusiyyət (McKeith 2017)

- Koqnitiv fluktuasiya — diqqət və oyanıqlıq dəyişkənliyi (saatlar–günlər).
- Vizual hallüsinasiyalar — tam formalaşmış, təkrarlanan (insan və heyvan surətləri); pasiyent hallüsinasiyaya nisbətən tolerant ola bilər.
- REM yuxu davranış pozuntusu (RBD) — koqnitiv enmədən illər əvvəl başlaya bilər.
- Parkinsonizm — bradikineziya, istirahət tremoru və ya rigidliyin — bunlardan birinin və ya bir neçəsinin olması (tremor Parkinson xəstəliyindəkindən adətən daha yüngül olur).

İndikativ biomarkerlər

- dopamin daşıyıcısı sintiqrafiyası (DAT-SPECT/PET, 123I-FP-CIT) — bazal qanqlionlarda presinaptik dopamin daşıyıcısının tutulmasının azalması.
- 123I-MIBG miokard sintiqrafiyası — patoloji (aşağı) tutulma.
- Polisomnoqrafiya atoniyasız REM yuxusunu təsdiqləyir.

Dəstəkləyici klinik xüsusiyyətlər

- Antipsixotiklərə ağır həssaslıq — neyroleptik malign sindroma bənzər reaksiya (diaqnostik alqoritmə daxil deyil).
- Postural qeyri-sabitlik, təkrarlanan yıxılmalar, sinkope, ağır vegetativ disfunksiya, hipersomniya, hiposmiya, sistemləşmiş sanrılar, apatiya, narahatlıq, depressiya.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (McKeith 2017)

Ehtimal olunan DLB (probable DLB): 2 və daha çox əsas klinik xüsusiyyət (indikativ biomarkerdən asılı olmayaraq) və ya 1 əsas xüsusiyyət + 1+ indikativ biomarker. Yalnız biomarkerlərə əsaslanaraq qoyula bilməz.

Mümkün DLB (possible DLB): indikativ biomarker olmadan yalnız 1 əsas klinik xüsusiyyət; və ya əsas klinik xüsusiyyət olmadan 1+ indikativ biomarker.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- McKeith I. və b. Neurology 2017 — diaqnostik konsensus.
- DAT-SPECT və ya 123I-MIBG miokard sintiqrafiyası — indikativ biomarkerlərdir (dəstəkləyici deyil).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və yaxın şəxslə söhbət (informant) — xüsusilə REM yuxu davranış pozuntusu (RBD) üçün.
2. MoCA, MMSE, neyropsixoloji (vizuo-məkan və icra funksiyaları üstünlük təşkil edir).
3. Neyroloji müayinə.
4. Beyin MRT (Alzheimer xəstəliyində olduğundan daha az hipokampal atrofiya).
5. DAT-SPECT (göstəriş olduqda).
6. Polisomnoqrafiya — RBD təsdiqi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Alzheimer (6D80)	Yaddaş pozuntusu üstünlük təşkil edir, vizual hallüsinasiyalar azdır.
Parkinson xəstəliyi demensiyası (PDD)	Demensiya parkinsonizmdən ≥ 1 il sonra (1-il qaydası).
Vaskulyar (6D81)	İnsult tarixçəsi, MRT.
Delirium (6D70)	Kəskin başlanğıc; fluktuasiya bənzərdir.
Gec başlanğıclı şizofreniya	Demensiya müşahidə olunmur.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- MoCA, neyropsixoloji.
- Polisomnoqrafiya (RBD).
- DAT-SPECT.
- Beyin MRT.

8. Müalicə

1. Asetilxolinesteraza inhibitorları (AXEI): rivastigmin, donepezil — DLB-də xüsusilə effektiv (kortikal asetilkolin azalması Alzheimer xəstəliyindən olduğundan daha güclüdür); rivastigmin McKeith I. Lancet 2000 RKİ.
2. Memantin — orta-ağır halda.
3. Parkinsonizm zamanı levodopa ehtiyatla təyin edilməlidir; psixotik simptomları gücləndirə bilər.
4. Vizual hallüsinasiyalar üçün qeyri-farmakoloji üsullar birinci sırada dayanır. Refrakter halda kvetiapin və ya klozapin aşağı dozada; tipik antipsixotiklər (haloperidol) və risperidon əks göstərişdir — ağır neyroleptik həssaslıq reaksiyası.
5. RBD — melatonin (3–12 mq gecə) və ya klonazepam (aşağı doza).
6. BPSD qeyri-farmakoloji birinci.
7. FDA yaşlı demensiya xəstələrində antipsixotiklər üçün qara qutu xəbərdarlığı tələb edir.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Rivastigmin — AXEI: DLB-də xüsusilə effektivdir; transdermal yamaq (patch) və oral formalar.
2. Kvetiapin/Klozapin (refrakter psixoz) — aşağı doza; klozapin ən təhlükəsizdir, lakin laborator nəzarət tələb edir.
3. Melatonin RBD üçün — 3–12 mq gecə.
4. DAT-SPECT — İndikativ diaqnostik biomarker.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- McKeith I. Lancet 2000 — rivastigmin DLB-də.
- NICE NG97 — DLB üçün rivastigmin və ya donepezil.
- Antipsixotik həssaslıq — McKeith I. icmalları.

9. Proqnoz

- Orta gözlənilən ömür diaqnozdan 5–8 il; Alzheimer xəstəliyində olduğundan bəzən daha qısa olur.
- Antipsixotiklərə qarşı reaksiya kritik komplikasiyadır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «DLB yalnız Alzheimer-in alt-tipidir»

Sübut: ayrı patoloji və nozoloji vahiddir; α-sinuklein amiloid-β/tau ilə müqayisədə; antipsixotik həssaslığı kritik fərq.

Mif 2: «Haloperidol DLB-də təhlükəsizdir»

Sübut: haloperidol və risperidon əks-göstərişdir — neyroleptik malign sindroma bənzər reaksiya, mortalitet riski yüksəkdir.

Mif 3: «Vizual hallüsinasiyalar həmişə müalicə tələb edir»

Sübut: bəzi pasiyent hallüsinasiyaya tolerantdır; əzab-əziyyət yaratmırsa fərqli yanaşma.

Mif 4: «Levodopa DLB-də parkinsonizmi tam sağaldır»

Sübut: levodopa cavab Parkinson xəstəliyindən az; psixotik simptomları gücləndirə bilər; balans tələb olunur.

Mif 5: «RBD əhəmiyyətsiz simptomdur»

Sübut: RBD α-sinüklein xəstəliyinin (DLB, Parkinson, MSA) prodromudur — 10–15 il ərzində gələcək inkişaf ehtimalı 80%-dən çoxdur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D82 Levi cisimcikli xəstəlik nəticəsində demensiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. MakKit İ.Q. və b. Levi cisimcikləri ilə demensiyanın diaqnostikası və idarə edilməsi: dördüncü konsensus məruzəsi. «Nevrologiya» (Neurology). 2017;89(1):88–100.
4. MakKit İ. və b. Levi cisimcikləri ilə demensiyada rivastiqminin effektivliyi: randomizə edilmiş, ikiqat kor, plasebo nəzarətli beynəlxalq tədqiqat. «Lancet». 2000;356(9247):2031–2036.
5. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG97 nömrəli təlimat. 2018.

XBT-11 **6D83**	**6D83** **FRONTOTEMPORAL DEMENSİYA (FTD)** **Frontotemporal dementia**
XBT-10 F02.0	Pik xəstəliyi zamanı demensiya
DSM-5-TR G31.09 + F02.8x	Frontotemporal lobar degenerasiyaya görə ağır və ya yüngül neyrokoqnitiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Frontotemporal Demensiya (FTD; XBT-11: 6D83; DSM-5-TR: G31.09 + F02.8x) — frontal və/və ya temporal lobların atrofiyası nəticəsində inkişaf edən demensiya; tipik başlanğıc 45–65 yaş arasındadır (erkən başlayan demensiyalardan ən sıx). Üç klinik varyant: bvFTD (davranış varyantı) və iki PPA forması (ilkin proqressiv afaziya — semantik və aqrammatik (non-fluent) variantlar).

2. Tarixçə

- Pick A. (1892) — «Pick xəstəliyi» — frontotemporal atrofiyanın təsviri.
- Neary D. və b. (1998) — FTD klinik konsensus meyarları.
- Rascovsky K. və b. (2011) — bvFTD yenilənmiş meyarlar.

3. Epidemiologiya

- 65 yaşa qədər demensiya hallarının 5–10%; 65 yaşdan sonra Alzheimer xəstəliyi üstünlük təşkil edir.
- Cins: bərabər.
- Ailə tarixçəsi halların 40%-dən çoxunda müşahidə olunur.
- Komorbidlik: ALS (amiotrofik lateral skleroz) — FTD-ALS spektrumu (C9orf72 mutasiyası).

4. Etiologiya və patogenez

- Genetik (40%) — C9orf72 (ən sıx), MAPT, GRN mutasiyaları.

- Patoloji — tau (Pick cisimcikləri, MAPT), TDP-43 (TDP-43A, B, C, D, GRN, C9orf72), FUS proteinləri.

5. Klinik təzahürlər

bvFTD (Davranış Varyantı, təxminən 60% FTD)

- Erkən şəxsiyyət dəyişikliyi — apatiya, dezinhibisiya, sosial uyğun olmayan davranış, empatiya itkisi.
- Stereotipik davranış (ritualistik).
- Hiperoral davranış (qida dəyişikliyi, «şirniyyata həvəs» (ing. sweet tooth)).
- İcra funksiyası əhəmiyyətli pozulur; yaddaş və vizuo-məkan funksiyaları başlanğıcda nisbətən saxlanılır.

PPA — İlkin proqressiv afaziya (ing. Primary Progressive Aphasia)

- Aqrammatik variant (non-fluent variant, nfvPPA) — qrammatika çətinliyi, ləng nitq apraksiyası.
- Semantik variant (semantic variant, svPPA) — söz mənası itkisi, agnoziya; səlis, lakin boş nitq.
- Loqopenik variant — Alzheimer xəstəliyi ilə əlaqəlidir, ayrıca variant kimi qəbul edilir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (Rascovsky 2011 bvFTD; Gorno-Tempini 2011 PPA)

bvFTD (ehtimal olunan): 6 davranış simptomundan ən azı 3-ü (dezinhibisiya, apatiya, empatiya itkisi, stereotipik davranış, hiperoral davranış, icra funksiyasının pozulması) + funksional pozulma + neyrovizuallaşdırma dəstəyi.

PPA: dil əsas çatışmazlıq; klinik və neyrovizuallaşdırma əsasında alt-varyant.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Rascovsky K. və b. Brain 2011 — bvFTD.
- Gorno-Tempini M.L. və b. Neurology 2011 — PPA.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + informant (davranış dəyişikliyi).
2. Neyropsixoloji test batareyası (icra funksiyası, dil).

3. Beyin MRT — frontal və/və ya temporal atrofiya.
4. FDG-PET — hipometabolizm.
5. Genetik test (ailə tarixçəsi).
6. ALS skrininq (klinik və ya elektromiografiya).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Alzheimer (6D80)	Yaddaş dominant, gec başlanğıc.
Gec başlanğıclı şizofreniya	Atrofiya yox.
Maniya, depressiya	Affektiv epizodlar.
Bipolyar pozuntu	Affektiv siklik.
Şəxsiyyət pozuntusu	Davamlı, uzunmüddətli; FTD-də dəyişiklik yenidir.
Beyin şişi	MRT.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Frontal Qiymətləndirmə Batareyası (ing. FAB, Frontal Assessment Battery), neyropsixoloji.
- MRT, FDG-PET.
- Genetik test.
- ALS skrininq.

8. Müalicə

1. Xəstəliyin gedişatını dəyişən spesifik dərman yoxdur — patohistoloji prosesə yönəlmiş müalicə hələ təsdiqlənməyib (klinik tədqiqatlar davam edir).
2. AChEI — FTD-də effektivsiz və ya zərərlidir (davranışı pisləşdirə bilər); Alzheimer xəstəliyindən fərqli olaraq.
3. SSGİ — bvFTD-də davranış simptomları (dezinhibisiya, kompulsivlik, depressiya) üçün təyin edilir; sübut bazası məhduddur.
4. Trazodon — agitasiya üçün; Lebert F. və b. tədqiqatları.
5. Atipik antipsixotik — yalnız ağır davranış simptomlarında, qısamüddətli, FDA black box qaydası.

6. Qayğı göstərənə dəstək və psixoedukasiya kritik (davranış simptomları ailə üçün çətindir).
7. Qidalanma dəstəyi (hiperoral davranışa nəzarət).
8. Hüquqi-maliyyə planlaşdırma.

8.1 Müalicə metodikaları

1. SSGİ bvFTD üçün — Citalopram, sertralin — davranış simptomları.
2. Trazodon — agitasiya, yuxu pozuntusu üçün.
3. Qeyri-farmakoloji üsullar — Mühitin dəyişdirilməsi, struktur, qayğı göstərənin təlimi.
4. Nitq və dil terapiyası (ing. SLT, Speech-Language Therapy) — PPA üçün; kompensasiyaedici strategiyalar.
5. Genetik Konsultasiya — Ailə üzvləri üçün.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE NG97 — FTD üçün AChEI tövsiyə etmir.
- Lebert F. və b. Dement Geriatr Cogn Disord 2004 — trazodon.

9. Proqnoz

- Diaqnozdan sonra orta gözlənilən ömür 6–11 il; FTD-ALS halında bu müddət daha qısadır (təqribən 3 il).
- Bəzi mutasiyalarda sürətli enmə müşahidə olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «FTD Alzheimer-in alt-tipidir»

Sübut: ayrı patoloji və klinik vahid; tau, TDP-43 və FUS patologiyaları müşahidə olunur; AChEI effektiv deyil.

Mif 2: «AChEI bütün demensiyalarda istifadə oluna bilər»

Sübut: FTD-də AChEI effektivsiz və ya zərərli; NICE NG97 tövsiyə etmir.

Mif 3: «Davranış dəyişikliyi yalnız psixiatrik problemdir»

Sübut: erkən başlayan davranış dəyişikliyi (45–65 yaş) FTD şübhəsi doğurmalıdır; neyrovizualizasiya vacibdir.

Mif 4: «Ailə tarixçəsi olmasa FTD genetik deyil»

Sübut: Halların 40%-də ailə tarixçəsi müəyyən edilir; sporadik də mümkündür; C9orf72 ekspansiya gizli ola bilər.

Mif 5: «FTD pasiyentin davranışı iradi»

Sübut: davranış dəyişikliyi neyrobioloji — frontal lob disfunksiyası; iradi nəzarət pozulmuşdur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6D83 Frontotemporal lobar degenerasiya nəticəsində demensiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Raskovski K. və b. Frontotemporal demensiyanın davranış variantı üçün yenidən işlənmiş diaqnostik meyarların həssaslığı. «Beyin» (Brain). 2011;134(Pt 9):2456–2477.
4. Qorno-Tempini M.L. və b. Birinci dərəcəli proqressiv afaziyanın və onun variantlarının təsnifatı. «Nevrologiya» (Neurology). 2011;76(11):1006–1014.
5. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). NG97 nömrəli təlimat. 2018.
6. Leber F. və b. Frontotemporal demensiya: trazodonla randomizə edilmiş nəzarətli sınaq. «Demensiya və Geriatrik Koqnitiv Pozuntular» (Dement Geriatr Cogn Disord). 2004;17(4):355–359.

6E20–6E2Z PERİNATAL POZUNTULAR

Hamiləlik, doğuş və ya zahılıq dövrü ilə əlaqəli psixi və ya davranış pozuntuları (ing. Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium)

XBT-11 **6E20**	**6E20 HAMİLƏLİK, DOĞUŞ VƏ YA DOĞUŞDAN SONRAKI DÖVR İLƏ ƏLAQƏLİ PSİXİ VƏ YA DAVRANIŞ POZUNTULARI, PSİXOTİK SİMPTOMSUZ** **Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium, without psychotic symptoms**
XBT-10 F53.0	Digər rubrikalarda təsnif olunmayan, doğuşdan sonrakı dövrlə əlaqədar yüngül psixi pozuntular və davranış pozuntuları
DSM-5-TR —	«Peripartum başlanğıclı» spesifikator (DSM-5-TR-də ayrıca kateqoriya yoxdur)

1. Tərif və nozologiya

Postnatal depressiya (XBT-11: 6E20 Mental and Behavioural Disorders Associated with Pregnancy, Childbirth or the Puerperium; DSM-5-TR: F32.x / F33.x Major Depressive Disorder with peripartum onset specifier) — doğuşdan sonra (tipik ilk 6 ay; bəzi göstərişlərdə 1 il) inkişaf edən böyük depressiv epizod (TDP). Qadınların 10 –15%-inə təsir edir.

2. Tarixçə

- Marcé L.V. (1858) — doğuşdan sonrakı psixozun və depressiyanın ilk klinik təsviri.
- EPDS — Cox J.L. və b. (1987) — Edinburgh Postnatal Depression Scale.
- NICE CG192 (2014, 2018) — antenatal və postnatal psixi sağlamlıq.
- FDA — breksanolon (2019), zuranolon (2023) — doğuşdan sonrakı depressiya üçün ilk xüsusi təsdiqlənmiş preparatlar.

3. Epidemiologiya

- Yayılma: 10–15% (yüksək gəlirli ölkələrdə), 20–30% (aşağı və orta gəlirli ölkələrdə).
- «Körpə hüznü» (baby blues) — daha yüngül, qısamüddətli (1–2 həftə) — 50 –80% qadınlarda; klinik müdaxilə tələb etmir.
- Komorbidlik: narahatlıq, OKP, panik.
- Risk amilləri: əvvəlki depressiya, ailə tarixçəsi, hamiləlikdə depressiya, partnyor dəstəyi yoxluğu, sosial-ekonomik stress.

4. Etiologiya və patogenez

- Hormonal — doğuşdan sonra estrogen və progesteronun kəskin enməsi; allopregnanolon disrequlyasiyası.
- Yuxu pozulması yenidoğulmuşun qulluğu ilə əlaqədardır.
- Psixososial stress, münasibətlər, sosial dəstək.
- Genetik və əvvəlki affektiv pozuntu tarixçəsi.

5. Klinik təzahürlər

- Major depressiv epizod simptomları (yuxu pozuntusu, iştahsızlıq, anhedoniya, dəyərsizlik, intihar (suisid) fikirləri).
- Spesifik xüsusiyyətlər: körpəyə qarşı affektiv distans, uşaq bağlanmasında çətinlik, ana rolunun öhdəsindən gələ bilməməsi inamı, körpəyə zərər haqqında müdaxiləedici (intruziv) fikirlər (eqo-distonik — OKP-ə bənzər; postnatal psixozdan fərqli).
- İntihar riski və nadir hallarda körpəöldürmə (infantisid) (postnatal psixozda daha yüksək).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

Major depressiv epizod meyarları (DSM-5-TR 5+ simptom 2 həftə; XBT-11) + peripartum başlanğıc spesifikatoru (peripartum onset specifier) (DSM-5-TR — hamiləlik və ya doğuşdan sonrakı 4 həftə ərzində; XBT-11 — zahılıq dövrü ilə məhdudlaşır (doğuşdan sonrakı ilk 6 həftə)).

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG192 (2014, 2018) — diaqnoz və müalicə.
- ACOG Committee Opinion 757 (2018) — perinatal depressiya skrininq.
- USPSTF (ABŞ Profilaktik Xidmətlər üzrə İşçi Qrupu) — hamilə və doğuşdan sonrakı dövrdə olan qadınlarda skrininq.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale, 10 maddə) — qızıl standart skrininq; kəsmə həddi (cut-off) ≥ 10 — mümkün depressiya (həssas skrininq həddi), ≥ 13 — ehtimal olunan major depressiya.
2. Klinik müsahibə (hospitalizasiya və ya intihar riskinin qiymətləndirilməsi).
3. Postnatal psixoz fərqi — psixotik simptomlar varsa təcili hospitalizasiya.
4. Tibbi qiymətləndirmə — tiroid (postpartum tiroidit), anemiya.
5. Komorbid narahatlıq, OKP skrininq.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
«Baby blues»	≤ 2 həftə, yüngül, klinik müdaxilə tələb etmir.
Postnatal psixoz (6E21)	Psixotik simptomlar; təcili hospitalizasiya.
Bipolyar depressiv epizod	Manik/hipomanik epizod tarixçəsi.
Postpartum tiroidit	TSH.
Anemiya	Hemoqlobin.
Postnatal OKP	Eqo-distonik intruzivlər ilə körpəyə zərər; postnatal depressiya ilə komorbiddir.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- EPDS, PHQ-9.
- C-SSRS — intihar və körpəyə zərər riski.
- TSH, hemoqlobin.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG192, ACOG, APA)

1. Yüngül–orta: psixoterapiya birinci sıra koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) və şəxsiyyətlərarası terapiya (İPT), xüsusilə peripartum dövrə uyğunlaşdırılmış.
2. Orta-ağır: psixoterapiya + SSGİ. Əmizdirmə kontekstində:
    - Sertralin (südə keçməsi ən az olan) və paroksetin — birinci sıra;
    - Fluoksetin uzun yarımömrə malik olduğundan ehtiyatla təyin edilir;
    - Sitalopram, essitalopram — uyğundur.
3. Refrakter ağır postnatal depressiya (PPD):
    - Breksanolon (Zulresso) — venadaxili (IV) 60 saatlıq infuziya; FDA 2019 təsdiqi; risk qiymətləndirmə və azaltma strategiyası (REMS) proqramı çərçivəsində klinikada nəzarət; sürətli effekt.
    - Zuranolon (Zurzuvae) — daxilə qəbul üçün 14 günlük kurs; FDA 2023 təsdiqi; daha əlverişli.
4. EKT — psixotik depressiya, ağır intihar riski, qida qəbulunun pozulması, hamiləlikdə də təhlükəsiz.
5. Ailə dəstəyi, həmyaşıd dəstəyi (məsələn, postnatal depressiya üzrə yardım xətti).
6. Sosial xidmət və ana–körpə bağlanmasının (bonding) dəstəklənməsi.
7. Yuxu hijyeni və ailə üzvlərinin gecə baxımına cəlb olunması.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Perinatal Şəxslərarası Terapiya (IPT) — Stüart (Stuart S.), Robertson (Robertson M.) — Ana rolunun dəyişməsi, partnyorla münasibətlər, sosial dəstək sistemi.
2. KDT Perinatal Uyğunlaşdırılmış — Koqnitiv təhriflər, davranış aktivasiyası.
3. Breksanolon (Zulresso) — venadaxili 60 saatlıq infuziya; tətbiqi yalnız REMS proqramı çərçivəsində klinikada mümkündür (təkrar təsvir çıxarılmalıdır).

4. Edinburq Postnatal Depressiya Şkalası (ing. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) — 10 maddəlik özünüqiymətləndirmə.
5. EKT hamiləlikdə və əmizdirmə dövründə yalnız ciddi göstərişlər zamanı tətbiq edilir; ağır refrakter halda.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG192 — sertralin və paroksetin əmizdirmədə birinci sıra.
- Louik C. və b. NEJM 2007, Huybrechts K.F. və b. NEJM 2014 — SSGİ hamiləlikdə kardial malformasiyalar (paroksetin diqqətlə).
- Meltzer-Brody S. və b. Lancet 2018 — brexanolone RKİ.

9. Proqnoz

- Adekvat müalicə ilə 70–80% remissiya.
- Sonrakı hamiləliklərdə residiv riski (təxminən 25%).
- Müalicəsiz xronikləşmə və komorbidlik.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Postnatal depressiya (PPD) adi „körpə hüznü“dür (baby blues), keçicidir»

Sübut: baby blues ≤ 2 həftə, yüngül; PPD klinik depressiv epizod, müdaxilə tələb edir; uzun davam edə bilər.

Mif 2: «Antidepresanlar əmizdirmə dövründə təhlükəlidir»

Sübut: sertralin və paroksetin əmizdirmədə qəbul ediləndir; südə keçmə minimaldır; klinik məsləhət tələb olunur.

Mif 3: «Ana zəifdir, „özünü ələ almalıdır“»

Sübut: PPD klinik vəziyyətdir; intihar və infanticide riski mövcuddur; müdaxilə tələb edir.

Mif 4: «Brexanolone PPD-ni sağaldır»

Sübut: sürətli effekt göstərir, lakin xərc və klinikada nəzarət tələbi əhəmiyyətlidir; standart yanaşma SSGİ + psixoterapiya.

Mif 5: «PPD körpəyə təsir etmir»

Sübut: PPD ana ilə körpə arasındakı bağlanmaya (bonding), körpənin koqnitiv və emosional inkişafına təsir göstərir; erkən müdaxilə vacibdir.

Mif 6: «İntruziv (müdaxiləedici) fikirlər — körpəyə zərər vermək qorxusu — həmişə psixoz əlamətidir»

Sübut: postnatal OKP-də bu fikirlər eqo-distonikdir (pasiyent onlardan əzab çəkir, qaçınma davranışı göstərir); postnatal psixozda eqo-sintonik və davranışa keçə bilir — fərqli müdaxilə.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6E20 Hamiləlik, doğuş və lohusalıq dövrü ilə əlaqəli psixi və davranış pozuntuları. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). CG192 nömrəli təlimat: Antenatal və postnatal psixi sağlamlıq. 2014, 2018-ci il yenilənməsi.
4. Amerika Obstetriya və Ginekologiya Kolleci (ACOG). 757 nömrəli Komitə Rəyi: Perinatal depressiyanın skrininqi. 2018.
5. Koks C.L., Holden C.M., Saqovski R. Doğuşdan sonrakı depressiyanın aşkarlanması. 10 bəndlik Edinburq doğuşdan sonrakı depressiya şkalasının hazırlanması. «Britaniya Psixiatriya Jurnalı» (Br J Psychiatry). 1987;150:782–786.
6. Meltser-Brodi S. və b. Doğuşdan sonrakı depressiyada breksanolon inyeksiyası. «Lancet». 2018;392(10152):1058–1070.
7. Deliqiannidis K.M. və b. Doğuşdan sonrakı depressiyada zuranolonun plaseboya nisbətən təsiri. «JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry). 2021;78(9):951–959.
8. Luik K., Lin A.E., Verler M.M., Hernandes-Dias S., Mitçell A.A. Birinci trimestrdə seçici serotonin geri alım inhibitorlarından istifadə və anadangəlmə qüsurlar riski. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (N Engl J Med). 2007;356(26):2675–2683.
9. Huybreçts K.F., Palmsten K., Avorn C. və b. Hamiləlikdə antidepresanlardan istifadə və ürək qüsurları riski. «Nyu İngiltərə Tibb Jurnalı» (N Engl J Med). 2014;370(25):2397–2407.
10. Stuart S., Robərtson M. Şəxslərarası psixoterapiya: həkim üçün bələdçi. 2-ci nəşr. London: Hodder Arnold; 2012.

XBT-11 **6E21**	**6E21 HAMİLƏLİK, DOĞUŞ VƏ YA ZAHILIQ DÖVRÜ İLƏ ƏLAQƏLİ PSİXİ VƏ YA DAVRANIŞ POZUNTULARI, PSİXOTİK SİMPTOMLARLA** **Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium, with psychotic symptoms**
XBT-10 F53.1	Digər rubrikalarda təsnif olunmayan, doğuşdan sonrakı dövrlə əlaqədar ağır psixi və davranış pozuntuları
DSM-5-TR F23	DSM-5-TR || Qısamüddətli psixotik pozuntu (peripartum başlanğıc göstəricisi ilə)

1. Tərif və nozologiya

Postnatal Psixoz (PPP; XBT-11: 6E21; DSM-5-TR: peripartum başlanğıc göstəricisi ilə qısamüddətli psixotik pozuntu və ya bipolyar I pozuntu) — doğuşdan sonra (tipik ilk 2 həftə) kəskin başlanğıclı psixotik epizod; hallüsinasiyalar, sayıqlamalar, koqnitiv dezorqanizasiya, əhval dəyişkənliyi. Tibbi təcili haldır — körpə qətli (infantisid) riski təxminən 4%, ananın intihar riski isə yüksəkdir.

2. Tarixçə

- Marcé L.V. (1858) — postpartum psixoz klassik təsviri.
- Bergink V. və b. (2015) — 4-pilləli müalicə alqoritmi.
- NICE CG192 — doğuş ətrafı dövrdə psixiatrik vəziyyətlərə dair təlimat.

3. Epidemiologiya

- İnsidens (xəstələnmə tezliyi): hər 1000 doğuşa 1–2 hal düşür.

- Bipolyar pozuntu tarixçəsi olan qadınlarda 25–50%; əvvəlki PPP tarixçəsi olanlarda residiv riski 30–40% (profilaktikasız 44%-ə qədər).
- Komorbidlik: əksər hallarda əsas diaqnoz bipolyar pozuntudur.
- Mortalite: infantisid 4%, İntihar 5%-ə qədər (müalicəsiz).

4. Etiologiya və patogenez

- Hormonal amil — doğuşdan sonra estrogen və progesteron səviyyəsinin kəskin enməsi müşahidə olunur.
- Yuxu məhrumiyyəti.
- Bipolyar pozuntu yatkınlığı (əksər PPP — bipolyar epizod təzahürü).
- Ailə tarixçəsi.

5. Klinik təzahürlər

- Sürətli başlanğıc (24–72 saat, tipik ilk 2 həftə).
- Polimorf psixotik simptomlar — sayıqlamalar (xüsusilə körpə haqqında — körpənin «şeytan» və ya «tələb olunmuş» olması; ana «qurtarmalı»), hallüsinasiyalar.
- Əhval dəyişkənliyi — manik və ya depressiv komponentlər.
- Koqnitiv dezorqanizasiya, qarışıqlıq.
- Yuxu pozulması ağırdır.
- Davranış — Davranış — qəribə (bizar), həddindən artıq, körpə baxımının pozulması.
- Yüksək risk: ana intihar, körpəyə zərər (infantisid).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

Klinik diaqnoz: doğuşdan sonra kəskin başlanğıclı psixotik epizod; bipolyar manik və ya kəskin psixotik kateqoriyasında kodlanır; peripartum başlanğıc göstəricisi əlavə edilir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG192 — təcili tibbi vəziyyət.
- RCPsych (ing. Kral Psixiatrlar Kolleci) — perinatal psixiatrik xidmət standartları.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə — sürətli başlanğıc, simptom təbiəti.
2. Tibbi qiymətləndirmə — postpartum tibbi (tiroidit, infeksiya, ensefalopatiya, eklampsiya, B12 çatışmazlığı) istisna.
3. Laborator — TSH, tam qan, elektrolitlər, qaraciyər, böyrək, ammonyak, qlükoza, infeksiya markerləri.
4. Beyin MRT və EEQ — atipik təqdimat və ya neyroloji əlamətlər varsa (autoimmun ensefalit — anti-NMDA-R xüsusilə!).
5. Toksikoloji.
6. İntihar və infantisid riskinin qiymətləndirilməsi (Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası (C-SSRS); körpənin təhlükəsizliyi).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Postnatal depressiya (6E20)	Psixotik simptom yoxdur.
Postnatal OKP	Eqo-distonik intruzivlər; xəstəlik şüuru saxlanılır.
Delirium (6D70)	Diqqət dalğalanması; tibbi səbəb (infeksiya).
Anti-NMDA-R ensefalit	Atipik psixoz, hərəki simptomlar və tutmalar; BOS antikorları; klassik təzahür gənc qadınlarda müşahidə olunur
Eklampsiya/HELLP	Hipertenziya, proteinuriya, trombositopeniya.
Sheehan sindromu	Hipopituitarizm (doğuşdan sonrakı kütləvi qanaxma nəticəsində).

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Klinik psixiatrik və neyroloji.
- Yuxarıdakı tibbi panel.
- Anti-NMDA-R antikorlar (CSF) — atipik halda.
- C-SSRS, körpə təhlükəsizliyi.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (NICE CG192, Bergink 2015)

1. Təcili xəstəxana yatımı mütləqdir — ana və körpə üçün; mümkünsə ana-körpə bölməsində (Mother-Baby Unit, MBU).
2. Bergink 4-pilləli alqoritm (Am J Psychiatry 2015):
    - Pillə 1: Benzodiazepin (lorazepam) kəskin stabilizasiya;
    - Pillə 2: Atipik antipsixotik (olanzapin, kvetiapin, risperidon);
    - Pillə 3: litiumun əlavə edilməsi;
    - Pillə 4: EKT refrakter və ya katatonik xüsusiyyətlərdə.
3. Bipolyar əsas əksər halda — litium birinci sıra. Valproat uşaq doğa bilən (reproduktiv yaşda olan) qadınlarda əks-göstərişdir və yalnız Hamiləliyin Qarşısının Alınması Proqramının şərtləri yerinə yetirildikdə və effektiv kontrasepsiya təmin edildikdə istifadə oluna bilər; hamiləlik dövründə isə əks-göstərişdir (EMA/MHRA 2018).
4. Əmizdirmə qərarı — litium əmizdirmədə nisbi əks-göstərişdir (südə keçən); olanzapin və kvetiapin nisbətən təhlükəsiz; pasiyent və ailə ilə müzakirə.
5. Sonrakı hamiləliklərdə residiv riski yüksək (təxminən 30–40%) — profilaktik litium doğuşdan əvvəl və sonrakı dövrdə tövsiyə olunur.
6. EKT hamiləlikdə və doğuşdan sonrakı dövrdə təhlükəsizdir; effekti sürətlidir.
7. Multidissiplinar koordinasiya — psixiatr, mama-ginekoloq, pediatr, sosial işçi.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Berginkin dörd pilləli alqoritmi (Bergink) — Benzodiazepin → antipsixotik → litium → EKT.
2. Ana-Körpə Bölməsi (MBU — Mother-Baby Unit) — Ana və körpənin birgə hospitalizasiyası; bağlanmanın (bonding) qorunması və təhlükəsizlik.
3. EKT doğuşdan sonrakı dövrdə — hamiləlikdə və əmizdirmədə təhlükəsizdir; sürətli effekt; katatonik xüsusiyyətlərdə birinci sıra.
4. Profilaktik Litium Sonrakı Hamiləliklərdə — Bergink V. və b. Am J Psychiatry 2012 — peri-postpartum dövründə residiv profilaktikası.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG192 — Ana-Körpə Bölməsi (ing. Mother-Baby Unit) tövsiyəsi.
- Bergink V. və b. Am J Psychiatry 2015 — 4-pilləli alqoritm sübut bazası.

9. Proqnoz

- Adekvat müalicə ilə pasiyentlərin əksəriyyətində tam bərpa müşahidə olunur.
- Sonrakı hamiləliklərdə residiv yüksək (təxminən 30–40%).
- Bipolyar pozuntunun uzunmüddətli idarə edilməsi vacibdir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «PPP „ana hisslərinin“ güclü ifadəsidir»

Sübut: klinik psixotik vəziyyət; infantisid və intihar riski yüksəkdir; təcili müdaxilə.

Mif 2: «Ev şəraitində izləmək kifayətdir»

Sübut: NICE CG192 — xəstəxanaya yerləşdirmə mütləqdir; ana-körpə bölməsi (MBU) üstünlük təşkil edir.

Mif 3: «Əmizdirmə üçün antipsixotik və litium qadağandır»

Sübut: olanzapin və kvetiapin əmizdirmədə nisbətən təhlükəsiz; litium süd-keçər, lakin uşaq monitorinqi ilə tövsiyə oluna bilər; fərdi balans.

Mif 4: «Sonrakı hamiləlikdə təkrar olmayacaq»

Sübut: əvvəlki PPP tarixçəsində residiv təxminən 30–40% (profilaktikasız 44%-ə qədər); profilaktik plan vacibdir.

Mif 5: «Anti-NMDA-R ensefaliti nadirdir, axtarış tələb etmir»

Sübut: gənc qadında atipik psixoz + hərəki simptomlar + tutmalar Anti-NMDA-R ensefalitinin klassik təzahürüdür; antikor müayinəsi həyati əhəmiyyət daşıyır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6E21 Doğuşdan sonrakı psixoz. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Antenatal və doğuşdan sonrakı ruhi sağlamlıq: klinik idarəetmə və xidmətin təşkili (NICE CG192). 2014/2018.
4. Berqink V., Burqerhaut K.M., Korengevel K.M., Kamperman A.M., Huqendeyk V.Y., Lambreqtse-van den Berq M.P., Kuşner S.A. Doğuşdan

sonrakı dövrdə psixozun və maniyanın müalicəsi. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2015;172(2):115–123. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13121652

5. Berqink V., Burqerhaut K.M., Korengevel K.M., Kamperman A.M., Huqendeyk V.Y., Lambreqtse-van den Berq M.P., Kuşner S.A. Yüksək risk qrupunda olan qadınlarda doğuşdan sonrakı psixozun və maniyanın profilaktikası. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2012;169(6):609–615. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.11071047
6. Qraus F., Titulaer M.C., Balu R., Benseler S., Binqol K., Şah S., Dalmau X. Autoimmün ensefalitinin diaqnostikasına klinik yanaşma. «Lancet Nevrologiyası» (Lancet Neurol). 2016;15(4):391–404. https://doi.org/10.1016/s1474-4422(15)00401-9

6E40 PSİXOLOJİ VƏ DAVRANIŞ AMİLLƏRİ

Başqa yerlərdə təsnif edilən pozuntulara təsir edən psixoloji və ya davranış amilləri

XBT-11 **6E40**	**6E40 BAŞQA YERDƏ TƏSNİF EDİLƏN POZUNTULARA VƏ YA XƏSTƏLİKLƏRƏ TƏSİR EDƏN PSİXOLOJİ VƏ YA DAVRANIŞ AMİLLƏRİ** **Psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere**
XBT-10 F54	Digər başlıqlarda təsnif edilən pozuntular və ya xəstəliklərlə əlaqədar psixoloji və davranış amilləri
DSM-5-TR F54	Digər tibbi vəziyyətlərə təsir edən psixoloji amillər

1. Tərif və nozologiya

XBT-11: 6E40 Psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere; DSM-5-TR: başqa tibbi vəziyyətlərə təsir edən psixoloji amillər — somatik xəstəliyin gedişinə müdaxilə edən psixoloji amillər (depressiya, narahatlıq, dərmana riayət, stress, xəstəlik haqqında inanclar).

süni pozuntu (faktisioz) pozuntudan (6D50) və bədən narahatlığı pozuntusundan (6C20) fərqlidir — burada təsdiqlənmiş tibbi xəstəlik var, lakin psixoloji amillər gedişata təsir edir.

2. Tarixçə

- Alexander F. (1950) «psixosomatik tibb» anlayışını formalaşdırmışdır.

- Engel G.L. (1977) «biopsixososial model»i təklif etmişdir.
- Levenson J.L. (2018) — APA Textbook of Psychosomatic Medicine.

3. Epidemiologiya

- Universaldır — bütün xronik somatik xəstəliklərdə psixoloji amillər təsir göstərir.
- Kardiovaskulyar xəstəlikdə depressiya — 20–40%; diabet — 25%; xərçəng — 15–25%.
- Konsultativ-liaison psixiatriya xidmətindən istifadə geniş yayılmışdır.

4. Etiologiya və patogenez

Biopsixososial qarşılıqlı təsir — bioloji predispozisiya, psixoloji amillər və sosial kontekst.

5. Klinik təzahürlər

- Komorbid depressiya/narahatlıq xəstəliyə təsir göstərir (məs. miokard infarktından sonra ölüm göstəricisinin artması).
- Dərmana uyğunluğun (adherence) pozulması.
- Xəstəlik haqqında yanlış inanclar.
- Stress ilə xəstəlik gedişinin pisləşməsi müşahidə olunur.
- Davranış amilləri (siqaret çəkmə, alkoqol istifadəsi, pəhriz, fiziki passivlik).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Təsdiqlənmiş tibbi xəstəlik mövcuddur.

B. Psixoloji və ya davranış amillər xəstəliyin gedişinə müdaxilə edir:

1. Müalicə cavabını azaldır;
2. Sağlamlıq riskini artırır;
3. Patofizioloji prosesi pisləşdirir;
4. Tibbi müdaxiləyə ehtiyacı dəyişdirir.

C. SÜNİ POZUNTU, bədən narahatlığı pozuntusu və ya başqa psixi pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- DSM-5-TR və XBT-11 meyarları eynidir.
- Konsultasiya-liaison psixiatriyası modeli.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Tibbi xəstəliyin qiymətləndirilməsi.
2. Psixoloji amillərin identifikasiyası — depressiya (PHQ-9), narahatlıq (ÜTP-7), dərmana riayət (Morisky).
3. Davranış amilləri — siqaret, alkohol, pəhriz, fiziki aktivlik.
4. Komorbid psixiatrik pozuntu skrininq.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Somatik simptom pozuntusu (6C20)	Somatik şikayət dominant.
süni pozuntu (6D50)	Şüurlu yalan.
TDP komorbid xəstəliyə	Affektiv simptomlar müstəqil meyarlara çatır — ayrı diaqnoz.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PHQ-9, ÜTP-7, Morisky.
- Xəstəliyə xas şkalalar (DDS — Diabet distressi şkalası; Bek kardioloji şkalası)

8. Müalicə

1. İnteqrasiya olunmuş multidissiplinar yanaşma — somatik mütəxəssis, psixiatr və psixoloq.
2. Xəstəlik-spesifik psixososial müdaxilə:
    - Kardial KDT (miokard infarktından sonrakı depressiya);
    - Diabetin özünüidarə təhsili (DSME);
    - Onkoloji əzab-əziyyət monitorinqi;
    - Xronik ağrı KDT və ACT.
3. Antidepressant — xəstəlik-spesifik yan təsir profili:
    - Kardial — sertralin, essitalopram;
    - Onkoloji — mirtazapin (yuxu, iştah faydası);

- Xronik ağrı — duloksetin, amitriptilin.

4. Motivasiya müsahibəsi — davranış dəyişikliyi (siqaret, fiziki aktivlik).

8.1 Müalicə metodikaları

1. Konsultativ-liaison psixiatriyası — tibbi və cərrahi şöbələrdə inteqrasiya olunmuş xidmət.
2. kardial KDT — Post-MI depressiya idarəsi.
3. Diabetin Özünüidarə Təhsili (ing. DSME — Diabetes Self-Management Education) pasiyentin öz vəziyyətini idarə etməyi öyrənməsinə yönəlmiş strukturlu proqram.
4. Xronik ağrı üçün KDT və ACT — Williams Cochrane 2020.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- NICE CG91 — kardial pasiyentlərdə depressiyada KDT.
- Levenson J.L. APA Textbook of Psychosomatic Medicine 2018.

9. Proqnoz

İnteqrasiya olunmuş yanaşma ilə həm somatik, həm psixoloji nəticələr yaxşılaşır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Xəstəlik tamamilə psixoloji mənşəlidir»

Sübut: «biopsixososial» model — psixoloji amillər təsir göstərir, lakin somatik xəstəliyi tək başına yaratmır.

Mif 2: «Psixiatr xəstəlikdən „qaçır“»

Sübut: inteqrativ yanaşma — somatik və psixiatrik müdaxilə paralel.

Mif 3: «Alternativ tibb (yoqa, şüurlu diqqət) somatik xəstəliyi sağaldır»

Sübut: komplementar müdaxilələr adjunkt ola bilər; standart somatik müalicəni əvəzləmir (onkoloji, kardial).

Mif 4: «Pasiyenti „stress səbəbilə xəstələndin“ demək terapevtikdir»

Sübut: bu yanaşma günahlandırıcı və terapevtik münasibəti pozur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6E40 Başqa yerlərdə təsnif edilən pozuntulara və ya xəstəliklərə təsir edən psixoloji və ya davranış amilləri. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Levenson C.L. (red.). Amerika Psixiatriya Assosiasiyası Nəşriyyatının Psixosomatik Təbabət və Məsləhət-Əlaqə Psixiatriyası Dərsliyi. 3-cü nəşr. 2018.
4. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Kəskin koronar sindromlar (NICE NG185). 2020.
5. Vuhuli M.A., Vonq C.M. Depressiya və ürək-damar pozuntuları. «Klinik Psixologiya İllik İcmalı» (Annu Rev Clin Psychol). 2013;9:327–354. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185526

6E60–6E6Z İKİNCİ DƏRƏCƏLİ PSİXİATRİYA

İkinci dərəcəli psixi və ya davranış sindromları

XBT-11 **6E61**	**6E61 İKİNCİ DƏRƏCƏLİ PSİXOTİK SİNDROM** **Secondary psychotic syndrome**
XBT-10 F06.2	Üzvi sayıqlama (şizofreniyaya bənzər) pozuntusu
DSM-5-TR F06.2	Başqa tibbi vəziyyətə görə sayıqlamalı psixotik pozuntu

1. Tərif və nozologiya

İkincili Psixotik Sindrom (ing. XBT-11: 6E61 Secondary Psychotic Syndrome; DSM-5-TR: F06.2/F06.0 Psychotic Disorder Due to Another Medical Condition) — başqa tibbi vəziyyət (autoimmun, infeksion, endokrin, metabolik, neyroloji) və ya maddə istifadəsi ilə əlaqədar inkişaf edən psixotik epizod. Birinci sıra müdaxilə əsas etiologiyaya yönəlmiş müalicədir.

2. Tarixçə

- «Simptomatik psixoz» termini XX əsrdə formalaşdı.
- Dalmau J. (2007) — anti-NMDA-R ensefalit kəşfi; autoimmun psixozların öyrənilməsində yeni mərhələ.
- Graus F. və b. (2016) — autoimmun ensefalit klinik göstərişi.

3. Epidemiologiya

- Bütün ilk epizod psixoz hallarının 3–8%-i ikinci dərəcəli etiologiya ilə bağlıdır.
- Anti-NMDA-R ensefalit — gənc qadınlarda nadir, lakin geri çevrilə bilən psixoz; teratoma ilə əlaqəli paraneoplastik forma.
- Haşimoto ensefalopatiyası və lupus ensefalopatiyası da müşahidə olunur.

4. Etiologiya və patogenez

- Autoimmun: anti-NMDA-R, anti-LGI1, anti-CASPR2 ensefalit; Hashimoto (TPO antikorlar); lupus (NPSLE).
- İnfeksiyalar: insan immunoçatışmazlıq virusu (HIV), sifilis, herpes ensefaliti, COVID-19.
- Endokrin: hiper/hipotiroid, kortizol pozuntuları (Cushing, Addison), parathyroid pozuntuları (hiperkalsemiya).
- Metabolik: uremiya, qaraciyər ensefalopatiyası, hiponatriemiya, hipo/hiperqlikemiya, B12 çatışmazlığı, Wilson xəstəliyi.
- Neyroloji: beyin şişi, insult, epilepsiya (postiktal psixoz), demensiya.
- Maddə ilə induksiya olunmuş: amfetamin, kokain, kannabis, hallüsinogen, alkoqol kəsim sindromu, steroidlər.
- Paraneoplastik: ovari teratoması (anti-NMDA-R), kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi.

5. Klinik təzahürlər

- Psixotik simptomlar (sayıqlama, hallüsinasiya, dezorqanizə olunmuş davranış).
- Atipik xüsusiyyətlər (autoimmun ensefalitə xarakterik):
    - Sürətli başlanğıc;
    - Hərəki simptomlar (katatonik, distoniyalar, orofasial diskineziya);
    - Autonom pozulma (hipertenziya, taxikardiya, hipertermiya);
    - Tutmalar;
    - Şüur pozulması.
- Klassik psixoz (şizofreniya) ilə müqayisədə — atipik təqdimat şübhə yaradır.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Psixotik simptomlar.

B. Tibbi vəziyyət (autoimmun, infeksion, endokrin, metabolik, neyroloji) və ya maddə təsiri sübutu.

C. Psixoz delirium çərçivəsində baş vermir (lakin delirium ilə üst-üstə düşə bilər).

D. Başqa birincili psixotik pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Graus F. və b. Lancet Neurol 2016 — autoimmun ensefalit klinik yanaşması.
- XBT-11 — maddə ilə bağlı psixoz buraya aid deyil: o, maddə fəslindədir (6C40.6 alkohol, 6C41.6 kannabis və s.). 6E61 yalnız psixi pozuntular fəslinə aid olmayan sağlamlıq vəziyyətləri üçündür və əsas xəstəliyin diaqnozu ilə birlikdə qoyulur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik şübhə — yeni psixoz, xüsusilə atipik xüsusiyyətlər və ya gənc yaşda qadınlarda.
2. Tibbi qiymətləndirmə:
    - Tam qan, qaraciyər/böyrək, elektrolitlər (Na, Ca), qlükoza, ammonyak;
    - TSH, TPO antikorlar (Hashimoto);
    - Kortizol səviyyəsi (Cushing/Addison);
    - HIV, sifilis;
    - ANA, lupus paneli;
    - B12, folat, seruloplazmin (Wilson);
    - Toksikoloji skrininq.
3. Beyin MRT.
4. EEQ — konvulsiv olmayan status, ensefalit.
5. Lumbal punksiya — pleositoz, antikor paneli (anti-NMDA-R, anti-LGI1, anti-CASPR2, paraneoplastik).
6. Şişin axtarılması (paraneoplastik antikorlar pozitiv olduqda — yumurtalıqların ultrasəs müayinəsi (USG), çanaq MRT-i, döş qəfəsi KT-si).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Şizofreniya (6A20)	Tibbi səbəb yox; tipik klinik gediş.
Kəskin və keçici psixotik pozuntu (6A23)	İkincili səbəblər istisna.
Delirium (6D70)	Diqqət dalğalanması; psixoz delirium kontekstində.

Vəziyyət	Fərqləndirici
Maddə induksiyalı psixoz	Maddə istifadəsinin təsdiqlənməsi və zamanla əlaqəsi.
Demensiya psixotik xüsusiyyətlərlə	Koqnitiv enmə.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Yuxarıdakı laborator panel.
- MRT, EEQ.
- BOS antikor paneli.
- Şiş skrininqi.

8. Müalicə

1. Etioloji müalicə birinci sıradadır:
    - Autoimmun ensefalit — IV metilprednizolon 1 g × 5 gün → venadaxili immunoqlobulin (IVIG) və ya plazmaferez; ikinci sıra rituksimab, siklofosfamid;
    - Paraneoplastik — şişin müalicəsi (ovari teratoması cərrahi);
    - Endokrin — tiroid, kortizol, kalsium korreksiyası;
    - İnfeksion — antibiotik, antiviral;
    - Metabolik — pozuntunun korreksiyası;
    - Dərman induksiyalı — şübhəli preparatın kəsilməsi.
2. Simptomatik psixiatrik müdaxilə — etioloji müalicə nəticə verənə qədər:
    - Atipik antipsixotik (kvetiapin, olanzapin) — ehtiyatla;
    - Autoimmun ensefalit halında — tipik antipsixotik (haloperidol) əks-göstərişdir — neyroleptik malinq sindromu (NMS) riski və xəstəliyin gücləndirilməsi;
    - Benzodiazepin (lorazepam) — kəskin agitasiya.
3. EKT refrakter katatonik vəziyyətdə və ya autoimmun ensefalitdə alternativ müalicə üsuludur.

8.1 Müalicə metodikaları

1. İmmunoterapiya (ing. Autoimmun Ensefalit) — IV steroidlər → IVIG → plazmaferez → rituksimab/siklofosfamid.
2. Şişin Müalicəsi (Paraneoplastik) — Cərrahi və ya onkoloji müalicə.

3. Atipik Antipsixotik Simptomatik — Etioloji müalicə nəticə verənə qədər; kvetiapin, olanzapin üstün.
4. EKT refrakter halda — katatonik və ya immunoterapiyaya cavab verməyən autoimmun ensefalitdə effektivdir.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Graus F. və b. Lancet Neurol 2016 — autoimmun ensefalit protokolları.
- APA Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry (Levenson).

9. Proqnoz

- Əksər halda etioloji müalicəyə cavab verir; geri çevrilə bilən vəziyyətdir.
- Anti-NMDA-R ensefalitində erkən immunoterapiya ilə 75% yaxşı bərpa müşahidə olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «İlk epizod psixozu həmişə şizofreniyadır»

Sübut: 3–8% ikincili etiologiyalı; atipik xüsusiyyətlər diqqət tələb edir; tibbi qiymətləndirmə birinci epizod psixozda mütləqdir.

Mif 2: «Tipik antipsixotik (haloperidol) hər psixotik epizod üçün təhlükəsizdir»

Sübut: autoimmun ensefalitə şübhə halında haloperidol və oxşar birinci nəsil antipsixotiklər qadağandır — NMS riski, xəstəliyin gücləndirilməsi.

Mif 3: «Anti-NMDA-R ensefaliti nadirdir, axtarış tələb etmir»

Sübut: gənc qadında atipik psixoz + hərəki simptomlar + tutmalar Anti-NMDA-R klassik təqdimatıdır; antikor testi həyat xilas edir; geri çevrilə bilən vəziyyət.

Mif 4: «Tibbi səbəb tapılmasa, psixiatrik diaqnoz qoyulur — daha çox axtarmaq lazım deyil»

Sübut: atipik klinik təqdimat genişləndirilmiş axtarış tələb edir (BOS, MRT, paraneoplastik panel).

Mif 5: «İmmunoterapiya psixiatrik vəziyyət üçün uyğun deyil»

Sübut: autoimmun ensefalitə sübut varsa, immunoterapiya birinci sıra; standart antipsixotiklər təsirsizdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6E61 İkinci dərəcəli psixotik sindrom. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Qraus F., Titulaer M.C., Balu R., Benseler S., Binqol K., Şah S., Dalmau X. Autoimmün ensefalitinin diaqnostikasına klinik yanaşma. «Lancet Nevrologiyası» (Lancet Neurol). 2016;15(4):391–404. https://doi.org/10.1016/s1474-4422(15)00401-9
4. Dalmau X., Qlavaçuk E., Huqhes E.Q., Rossi X.E., Penq Ks., Lai M., Dessain S.K., Rozenfeld M.R., Balise-Qordon R., Linke T., Bukovski B., Titulaer M.C. Anti-NMDA reseptor ensefaliti: hallar seriyası və antitellərin təsirlərinin təhlili. «Lancet Nevrologiyası» (Lancet Neurol). 2008;7(12):1091–1098. https://doi.org/10.1016/s1474-4422(08)70224-2
5. Levenson C.L. (red.). Amerika Psixiatriya Assosiasiyası Nəşriyyatının Psixosomatik Təbabət və Məsləhət-Əlaqə Psixiatriyası Dərsliyi. 3-cü nəşr. 2018.

XBT-11 **6E62**	**6E62 İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ƏHVAL-RUHİYYƏ SİNDROMU** **Secondary mood syndrome**
XBT-10 F06.3	Əhvalın üzvi mənşəli (affektiv) pozuntusu
DSM-5-TR F06.3x	Başqa tibbi vəziyyətə görə depressiv pozuntu

1. Tərif və nozologiya

İkincili Əhval-Ruhiyyə Sindromu (ing. XBT-11: 6E62 Secondary Mood Syndrome; DSM-5-TR: F06.3x Mood Disorder Due to Another Medical Condition) — depressiv, manik və ya qarışıq əhval epizodları başqa tibbi vəziyyət, maddə və ya dərman təsiri nəticəsində meydana gəlir.

2. Tarixçə

«Üzvi affektiv pozuntu» termini XX əsrdə yaranmışdır; biopsixososial model klinik praktikada tətbiq olunur.

3. Epidemiologiya

- Xronik tibbi xəstəliklərdə depressiv simptomlar geniş yayılmışdır; onların bir hissəsi klinik depressiv epizod səviyyəsinə çatır.
- Steroid induksiyalı əhval pozuntuları — yüksək dozada prednizolon zamanı 5–18% maniya və ya hipomaniya, depressiya.
- İnterferonla induksiya olunmuş depressiya — hepatit C virusunun (HCV) müalicəsində 20–40%.
- İnsult sonrası depressiya — 30%.

4. Etiologiya və patogenez

- Endokrin — hipotiroid (depressiya), hipertiroid (maniyaya bənzər), Cushing, Addison.
- Neyroloji — insult (sol frontal — depressiya, sağ — maniya), Parkinson xəstəliyi, dağınıq skleroz, beyin şişi, demensiya, kəllə-beyin travması.
- Maddə/dərman — steroidlər, interferon, dopamin agonistləri, izotretinoin, β-blokator, antikonvulsant.
- Metabolik — uremiya, B12, folat.
- İnfeksion — HIV, sifilis, COVID.
- Autoimmun — lupus, Hashimoto.
- Onkoloji — pankreas xərçəngi (klassik depressiv təzahür), paraneoplastik.

5. Klinik təzahürlər

- Depressiv, manik, qarışıq, hipomanik epizod simptomları.
- Tibbi vəziyyət və ya maddə ilə zaman bağlılığı.
- Klassik affektiv pozuntu üçün xarakterik olmayan xüsusiyyətlər (gec başlanğıc, atipik təqdimat).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Davamlı əhval pozuntusu (depressiv, manik və ya qarışıq).

B. Tibbi vəziyyət və ya maddə təsiri sübutu.

C. C. Birincili affektiv pozuntu ilə daha yaxşı izah olunmur.

D. Delirium kontekstində baş vermir.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- XBT-11 — maddə ilə bağlı əhval pozuntusu buraya AİD DEYİL: o, maddə fəslindədir. 6E62 yalnız psixi pozuntular fəslinə aid olmayan sağlamlıq vəziyyətləri üçündür və əsas xəstəliyin diaqnozu ilə birlikdə qoyulur.
- Konsultativ-əlaqələndirmə protokolları tətbiq olunur.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + tibbi tarixçə.
2. Tibbi və laborator qiymətləndirmə (TSH, B12, kortizol, böyrək, qaraciyər).
3. Dərman siyahısının nəzərdən keçirilməsi.
4. Beyin görüntüləməsi (insult, MS, şiş).
5. Toksikoloji.
6. Komorbid pozuntular.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
TDP birinci (6A70/6A71)	Tibbi səbəb yox.
Bipolyar pozuntu, birincili	Affektiv epizod tarixçəsi tibbi səbəb olmadan.
Uyğunlaşma pozuntusu (6B43)	Stress amilinə cavab.
Delirium (6D70)	Diqqət dalğalanması.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PHQ-9, MADRS, YMRS.
- Laborator: TSH, B12, kortizol, ANA, böyrək, qaraciyər.
- MRT atipik halda.
- C-SSRS.

8. Müalicə

1. Etioloji müalicə — tibbi vəziyyət və ya dərman korreksiyası.

2. Simptomatik psixiatrik müalicə:
    - Depressiv — SSGİ (xəstəliyə uyğun seçim; kardial — sertralin, essitalopram; onkoloji — mirtazapin);
    - Manik — antipsixotik (kvetiapin, olanzapin); steroidlərlə törədilmiş maniya halında steroidin azaltma və ya antipsixotik;
    - Qarışıq və ya refrakter — EKT.
3. Multidissiplinar

8.1 Müalicə metodikaları

1. SSGİ xəstəliyə uyğun seçim — kardial, onkoloji və neyroloji kontekstə uyğun.
2. EKT — Refrakter və ağır halda.

9. Proqnoz

Etioloji müdaxilə ilə əksər remissiya.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Tibbi xəstəliyi olan pasiyentdə depressiya „normal“dır»

Sübut: klinik depressiya tibbi vəziyyətin gedişini pisləşdirir; aktiv müdaxilə tələb edir.

Mif 2: «Steroidlərlə törədilmiş maniya öz-özünə aradan qalxır»

Sübut: dozanın azaldılması və ya antipsixotik əlavə tələb olunur.

Mif 3: «Antidepressant hipotiroiddə birinci pillə»

Sübut: tiroid korreksiyası birinci; antidepressant qalıq simptomlar üçün.

Mif 4: «İnterferon depressiyası nadir»

Sübut: hepatit C virusu (HCV) interferon terapiyasında 20–40% — aktiv izləmə tələb olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6E62 İkinci dərəcəli əhval sindromu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.

3. Levenson C.L. (red.). Amerika Psixiatriya Assosiasiyası Nəşriyyatının Psixosomatik Təbabət və Məsləhət-Əlaqə Psixiatriyası Dərsliyi. 3-cü nəşr. 2018.
4. Robinson R.Q., Xorce R.E. İnsultdan sonrakı depressiya: icmal. «Amerika Psixiatriya Jurnalı» (Am J Psychiatry). 2016;173(3):221–231. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15030363

XBT-11 **6E63**	**6E63 İKİNCİLİ TƏŞVİŞ SİNDROMU** **Secondary anxiety syndrome**
XBT-10 F06.4	XBT-10 / F06.4 || Üzvi təşviş pozuntusu
DSM-5-TR F06.4	Başqa tibbi vəziyyətə görə təşviş pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

İkincili Təşviş Sindromu (ing. XBT-11: 6E63 Secondary Anxiety Syndrome; DSM-5-TR: F06.4 Anxiety Disorder Due to Another Medical Condition) — narahatlıq, panik və ya obsesiv xarakterli simptomlar başqa tibbi vəziyyət və ya maddə təsiri kontekstində.

2. Tarixçə

Konsultasiya-liaison psixiatriya inkişafı; DSM-III-dən etibarən rəsmi kateqoriya.

3. Epidemiologiya

- Xroniki tibbi xəstəliklərdə narahatlıq tezliyi yüksəkdir (kardial, KOAH, endokrin).
- Hipertiroidizmdə 60–70% hallarda narahatlıq simptomu müşahidə olunur.
- Kafein, stimulyant induksiyalı narahatlıq.

4. Etiologiya və patogenez

- Endokrin — hipertiroid, feoxromositoma, hipoglikemiya.
- Kardial — aritmiya, miokard infarktı, mitral qapağın prolapsı.
- Respirator — KOAH, astma, ağciyər embolizmi.

- Neyroloji — TBİ, Parkinson, MS.
- Maddə/dərman — kafein, stimulyant, kortikosteroid, β-blokator (paradoksal), benzodiazepin/benzodiazepin və alkoqol abstinensiyası.
- Vestibular pozuntular.

5. Klinik təzahürlər

- ÜTP, panik atak, OKP-bənzər simptomlar tibbi vəziyyət kontekstində.
- Atipik xüsusiyyətlər (gec başlanğıc, fokus simptom).

6. Diaqnoz

Tibbi vəziyyətin sübutu, narahatlıq simptomları və zaman əlaqəsi əsas götürülür.

6.1 Mənbələr arasında fərqlər

DSM-5-TR və XBT-11 meyarları eynidir.

6.2 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Tibbi qiymətləndirmə — TSH, qlükoza, kardial, vestibular.
3. Dərman və kafein tarixçəsi.
4. Toksikoloji.

6.3 Differensial diaqnostika

- Birincili təşviş pozuntuları (6B00–6B0Z);;
- Delirium;
- Uyğunlaşma pozuntusu.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- ÜTP-7, HAM-A.
- TSH, qlükoza, elektrokardioqramma (EKQ).
- Toksikoloji.

8. Müalicə

1. Etioloji müalicə.
2. Simptomatik — SSGİ qalıq narahatlıq üçün; kəskin hallarda benzodiazepinlər qısamüddətli tətbiq olunur.

3. Kafeinin məhdudlaşdırılması.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Etioloji Müdaxilə — Tibbi vəziyyətin korreksiyası.
2. SSGİ Qalıq Narahatlıq üçün — Tibbi vəziyyət korreksiyasından sonra qalan simptomlar üçün.

9. Proqnoz

Etioloji müdaxilə ilə əhəmiyyətli yaxşılaşma.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Tibbi xəstəlikli pasiyentin narahatlığı „normal“dır»

Sübut: klinik narahatlıq tibbi vəziyyətin gedişini pisləşdirir; müdaxilə tələb edir.

Mif 2: «Hipertireozda anksiolitik birinci sıra»

Sübut: tiroid korreksiyası birinci; β-blokator (propranolol) simptomatik köməkçi vasitə.

Mif 3: «Kafein təhlükəsizdir»

Sübut: yüksək dozada panika, narahatlıq və taxikardiya yarada bilər; məhdudlaşdırma tövsiyə olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 6E63 İkinci dərəcəli təşviş sindromu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Levenson C.L. (red.). Amerika Psixiatriya Assosiasiyası Nəşriyyatının Psixosomatik Təbabət və Məsləhət-Əlaqə Psixiatriyası Dərsliyi. 3-cü nəşr. 2018.

YUXU-OYANIQLIQ POZUNTULARI (Sleep-wake disorders)

Yuxu-oyanıqlıq pozuntuları (sleep-wake disorders)

XBT-11 **7A00**	**7A00 XRONİKİ İNSOMNİYA** **Chronic insomnia**
XBT-10 F51.0	Qeyri-üzvi etiologiyalı insomniya
DSM-5-TR F51.01	İnsomniya pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Xronik insomniya (ing. XBT-11: 7A00; DSM-5-TR: F51.01 Insomnia Disorder) — yuxuya getməkdə çətinlik, yuxunu saxlaya bilməmə və/yaxud erkən oyanma; gündüz funksional pozulma. Müddət ≥ 3 ay, tezlik həftədə ≥ 3 dəfə olmalıdır.

2. Tarixçə

- DSM-IV — «Primary Insomnia»; DSM-5 (2013) — «Insomnia Disorder» — birincili/ikincili insomniya fərqi ləğv edilmişdir.
- AASM (ing. American Academy of Sleep Medicine) — Clinical Practice Guidelines (2021 KDT-I, 2017 pharmacological).
- European Insomnia Guideline (Riemann D. 2023).
- NICE TA922 (2023).

3. Epidemiologiya

- Ömürlük yayılma: xroniki insomniya 10–15%; insomniya simptomları 30–35%.
- Cins: qadınlarda 1,5 dəfə yüksək.
- Yaşla artır.
- Komorbidlik: TDP təxminən 50%, narahatlıq, ağrı, KOAH, sirkadian pozuntular.

4. Etiologiya və patogenez

- Spielman 3P modeli — meyillilik (predisposing), tətikləyici (precipitating), saxlayıcı (perpetuating).
- Hiperoyanıqlıq (hiperarousal) hipotezi — fizioloji və koqnitiv stimullaşma.
- Davranış amilləri — qeyri-müntəzəm cədvəl, kafein, alkoqol, ekrandan istifadə, yataq otağında qeyri-yuxu fəaliyyəti.

5. Klinik təzahürlər

- Yatma çətinliyi (yuxuya getmə), saxlamama (yuxunu davam etdirə bilməmə), erkən oyanma.
- Gündüz simptomları: yorğunluq, qıcıqlanma, konsentrasiya, iş/akademik pozulma, somatik (başağrısı, mədə-bağırsaq simptomları).
- Performansa təsir, qəza riski.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Yuxu çətinliyi (başlama, saxlama və ya erkən oyanma).

B. B. Adekvat yuxu imkanlarına baxmayaraq yuxu pozulur.

C. Gündüz funksional pozulma.

D. Müddət ≥ 3 ay, həftədə ≥ 3 dəfə.

E. Başqa yuxu pozuntusu, maddə, tibbi vəziyyət ilə tam izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM — KDT-I birinci sıra.
- NICE TA922 (2023) — daridoreksant yalnız KDT-I işləmədikdə və ya əlçatan olmadıqda; deməli KDT-I birinci pillədir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və 1–2 həftə ərzində yuxu gündəliyinin aparılması.
2. İnsomniya Şiddəti İndeksi (İŞİ), Pitsburq Yuxu Keyfiyyəti İndeksi (PSQİ).
3. Differensial — obstruktiv yuxu apnoesi (STOP-BANG), restless legs, sirkadian.
4. Komorbidlik (TDP, narahatlıq).

5. Polisomnoqrafiya yalnız atipik halda və ya başqa yuxu pozuntusu şübhəsi varsa.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Obstruktiv yuxu apnoesi (7A41)	Xoruldama, gündüz yuxululuğu; polisomnoqrafiya.
Sirkadian pozuntular (7A60)	Yuxu cədvəlinin sürüşməsi.
Ayaqlarda narahatlıq sindromu (RLS)	Akatiya ilə oxşar ayaq narahatlığı.
TDP ilə insomniya	Affektiv simptomlar dominant.
Hipertiroid	TSH.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- ISI, PSQI.
- Yuxu gündəliyi.
- STOP-BANG (YAPP), Epworth Sleepiness Scale.
- TSH, ferritin.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (AASM 2021, European Insomnia Guideline 2023, NICE TA922 2023)

1. KDT-I (ing. Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia) — birinci sıra; xronik insomniyada qızıl standart; farmakoterapiyadan üstün uzunmüddətli effektivlikdə (Mitchell M.D. BMC Fam Pract 2012 meta-analiz). 5 əsas komponent:
    - Stimul nəzarəti (Bootzin) — yataq yalnız yuxu üçün;
    - Yuxu məhdudiyyəti (Spielman) — yataqda qalma vaxtının yuxu vaxtına bərabər məhdudlaşdırılması;
    - Koqnitiv terapiya — yuxu ilə bağlı fəlakətləşdirmə düşüncələri üzərində işləmə;
    - Yuxu gigiyenası;
    - Rahatlama təlimi.
2. Digital KDT-I (Sleepio, SHUTi) — NICE HTG624 (2022): birinci pillə yardımda yuxu gigiyenası və ya yuxu dərmanı təklif olunacaq şəxslər üçün

xərcə qənaət edən seçim; üzbəüz KDT-I ilə birbaşa müqayisə sübut olunmayıb.

3. Farmakoterapiya — qısamüddətli (2–4 həftə), KDT-I cavab vermədikdə və ya əlçatan olmadıqda:
    - Z qrupu dərmanları (zolpidem, zopiklon, eszopiklon);
    - Benzodiazepin (temazepam) — tolerantlıq, asılılıq riski;
    - Daha yeni dərmanlar — suvoreksant, lemboreksant (oreksin antaqonistləri) — daha az asılılıq;
    - Doksepin aşağı dozada (3–6 mq);
    - Melatonin — sirkadian komponentdə və ya yaşlılarda; ramelteon (melatonin agonisti).
4. Yaşlılarda — Beers meyarları; benzodiazepin və antihistaminik (difenhidramin) — qaçınmaq lazımdır.
5. Komorbid depressiya — sedativ antidepresan (mirtazapin, trazodon) — uzunmüddətli istifadə üçün yan təsirlər nəzərə alınmalıdır.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Yuxusuzluq üçün koqnitiv-davranış terapiyası (KDT), 5 komponent — Stimul kontrolu, yuxu məhdudiyyəti, koqnitiv terapiya, yuxu hijyeni, rahatlama.
2. Rəqəmsal KDT-I (Digital) — Sleepio, SHUTi — internet əsaslı.
3. Oreksin Antaqonistləri — Suvoreksant, lemboreksant — daha az asılılıq potensialı.
4. Yuxusuzluq Şiddət İndeksi (İŞİ — İnsomniya Şiddəti İndeksi) — 7 maddəlik skrininq.
5. Yuxu Gündəliyi — 1–2 həftə ilkin göstəricilər.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM Clinical Practice Guideline for Behavioral and Psychological Treatments (Edinger J.D. 2021).
- European Insomnia Guideline (Riemann D. J Sleep Res 2023).
- NICE TA922 (2023) — dərmana keçməzdən əvvəl KDT-I sınanmalıdır.

9. Proqnoz

- KDT-I-yə cavab 70–80%, remissiya təxminən 40%; effekt uzunmüddətli saxlanılır.
- Müalicəsiz xronik gediş və komorbidlik (TDP, narahatlıq).

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Yuxu dərmanları insomniyanın əsas müalicəsidir»

Sübut: AASM 2021 — KDT-I birinci sıra; farmakoterapiya qısamüddətli köməkçi vasitədir; uzun müddətli istifadə tolerantlıq, asılılıq.

Mif 2: «Alkoqol yuxulamağa kömək edir»

Sübut: alkohol REM-i azaldır, gecə yarısı oyanma yaradır, xronik insomniyaya gətirir.

Mif 3: «Antihistaminik (difenhidramin) yaşlılarda təhlükəsizdir»

Sübut: Beers Criteria — antihistaminik yaşlılarda antikolinergik yan təsir (yıxılma, koqnitiv enmə); qaçınma.

Mif 4: «Valerian və kava insomniya üçün təhlükəsiz alternativdir»

Sübut: valerian — Leach M.J., Page A.T. Sleep Med Rev 2015;24:1–12 — effekt sübutu yetərsiz; kava hepatotoksiklik.

Mif 5: «8 saat yuxu hamı üçün lazımdır»

Sübut: fərdi tələbat 6–9 saat; əhəmiyyətli olan gündüz funksiyasıdır.

Mif 6: «Gecə ərzində oyanmaq zərərlidir»

Sübut: qısa oyanmalar normaldır; stimul nəzarəti prinsipi — 20 dəqiqə ərzində yuxuya gedə bilmirsənsə, qalxmaq tövsiyə olunur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 7A00 Yuxusuzluq pozuntuları. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı (DSM-5-TR). 2022.
3. Edinqer C.D., Arnedt C.T., Bertiş S., Karnei K.E., Harrington C.C., Lichtşteyn K.L., Lim M.M., Stepanski E.C., Troksel V.M., Çen Z. Böyüklərdə xroniki yuxusuzluq pozuntusunun davranış və psixoloji müalicəsi: Amerika Yuxu Təbabəti Akademiyasının (AASM) klinik təcrübə rəhbərliyi. «Klinik Yuxu Təbabəti Jurnalı» (J Clin Sleep Med). 2021;17(2):255–262. https://doi.org/10.5664/jcsm.8986
4. Riman D., Espi K.A., Altena E., Arnardottir E.S., Balyoni K., Bassetti K.L.A., Bastien S., Berzina N., Bjorvatn B., Dikeos D., Dolençq Groşely L.,

Ellis C.Q., Qarsiya-Borreqero D., Cofrua P.A., Qerstad M., Qonçalves M., Hertenşteyn E., Hodlmoze K., Xion T., Holzinqer B., Yanku K., Yansson-Fryumark M., Yarnefelt H., Yernelöv S., Yennum P.Y., Xaçatryan S., Krone L., Kayl S.D., Lansee Y., Lejer D., Lupusor A., Markeş D.R., Nissen K., Palaqini L., Paunio T., Peroqamvros L., Pevernaqie D., Şabus M., Şoçat T., Sentkirali A., Van Someren E. van Straten A., Vixniak A., Verbraecken Y., Şpigelhalder K. Avropa Yuxusuzluq Rəhbərliyi 2023: yuxusuzluğun diaqnostikası və müalicəsinə dair yenilənmə. «Yuxu Tədqiqatları Jurnalı» (J Sleep Res). 2023;32(6):e14035. https://doi.org/10.1111/jsr.14035

5. Mitçell M.D., Qaynes B., Vayatt T., Smit K.T. Yuxusuzluq üçün koqnitiv-davranış terapiyasının müqayisəli effektivliyi: sistematik icmal. «BMC Ailə Təcrübəsi» (BMC Fam Pract). 2012;13:40. https://doi.org/10.1186/1471-2296-13-40
6. Buysse C.C., Cermain A., Moul D.E., Franzen P.L., Brar L.K., Fletcher M.E., Qroyer S., Lorrain C.R., Reynolds K.F. Yaşlı böyüklərdə xroniki yuxusuzluğun qısa davranış müalicəsinin effektivliyi. «Daxili Təbabət Arxivləri» (Arch Intern Med). 2011;171(10):887–895. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2010.535
7. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). İnsomniya və insomniya simptomlarının müalicəsi üçün Sleepio. Səhiyyə Texnologiyaları üzrə Təlimat HTG624. London: NICE; 2022.
8. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Uzunmüddətli insomniyanın müalicəsi üçün daridoreksant. Texnologiyaların Qiymətləndirilməsi üzrə Təlimat TA922. London: NICE; 18 oktyabr 2023.

XBT-11 **7A20**	**7A20 NARKOLEPSİYA** **Narcolepsy**
XBT-10 G47.4	Narkolepsiya və katapleksiya
DSM-5-TR G47.4xx	Narkolepsiya

1. Tərif və nozologiya

Narkolepsiya (XBT-11: 7A20; DSM-5-TR: G47.4xx) — gündüz qarşısıalınmaz yuxu epizodları; iki tip: Tip 1 (katapleksiya ilə, oreksin-A/hipokretin çatışmazlıq) və Tip 2 (katapleksiya olmadan).

2. Tarixçə

- Gélineau J.B. (1880) — narkolepsiya termini.
- Mignot E. və b. (2000) — oreksin/hipokretin sisteminin kəşfi narkolepsiya etiologiyasında.

3. Epidemiologiya

- Prevalans: 100 000 nəfərdə 25–50 hal.
- Xəstəliyin başlanğıcı 10–25 yaş arasında olur (bimodal paylanma).
- Komorbidlik: YAPP, depressiv simptomlar, OKP.

4. Etiologiya və patogenez

- Tip 1 — oreksin-A neyronlarının autoimmun zədəsi (beyin-omurilik mayesində oreksin-A < 110 pg/ml); HLA-DQB1*06:02 güclü assosiasiya.
- H1N1 peyvəndi (Pandemrix, 2009) — Skandinaviya ölkələrində narkolepsiya tip 1 insidens artımı (Miller E. BMJ 2013).
- Tip 2 — etiologiya tam aydın deyil.

5. Klinik təzahürlər

Klassik tetrada

- Gündüz həddindən artıq yuxululuq — qaçınılmaz yuxu tutmaları.
- Katapleksiya (Tip 1) — emosional tətikləyicinin (gülmək, qəzəblənmək) təsiri ilə qəfil baş verən qismən və ya tam əzələ tonusu itkisi (gülmək, qəzəblənmək); şüur saxlanılır.
- Yuxu paralizi — yatma və ya oyanma keçidində hərəkət edə bilməmə.
- Hipnaqoji və hipnopompik hallüsinasiyalar — yuxu keçidində vizual/eşitmə hallüsinasiyaları.

Tamamlanmış tetrada nadir; EDS əsas xüsusiyyət.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. EDS ≥ 3 ay.

B. MSLT — orta yuxu latentliyi ≤ 8 dəqiqə və yuxu başlanğıcında REM dövrü (SOREMP) ≥ 2 (ing. Sleep Onset REM Period); və ya CSF oreksin-A < 110 pg/ml.

C. Tip 1 — katapleksiya + oreksin çatışmazlıq; Tip 2 — katapleksiya yoxdur, oreksin səviyyəsi normaldır.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Yuxu pozuntularının beynəlxalq təsnifatı, 3-cü nəşr (ICSD-3) — Amerika Yuxu Tibbi Akademiyası (AASM).
- Atipik hallarda HLA tipləşdirilməsi və beyin-omurilik mayesində oreksinin təyini aparılır.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə.
2. Gecə polisomnografiyası (PSG) və gündüz Çoxsaylı Yuxu Latentliyi Testi (MSLT) qızıl standart hesab olunur.
3. CSF oreksin — selektiv.
4. HLA-DQB1*06:02 — supportiv.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
İdiopatik hipersomniya (7A21)	SOREMP < 2.
YAPP (7A41)	AHI yüksək.
Tutma	Şüur itkisi; EEQ.
Sinkope	Kardiovaskulyar səbəb.
Funksional/psixogen	Tipik klinik mənzərənin polisomnografiya və Çoxsaylı Yuxu Latentliyi Testinin nəticələri ilə uyğunsuzluğu.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Epworth.
- PSG + MSLT.
- CSF oreksin, HLA-DQB1*06:02.

8. Müalicə

1. EDS: modafinil, armodafinil, solriamfetol, pitolisant; stimulyantlar (metilfenidat, amfetamin) refrakter halda.

2. Katapleksiya: natrium oksibat (Xyrem) — qızıl standart; yeni forma — kalsium, maqnezium, kalium və natrium oksibatı (Xywav, FDA 2020, aşağı natrium tərkibli); SSGİ/SNGİ (venlafaksin, fluoksetin); pitolisant.
3. Davranış — planlaşdırılmış gündüz yuxular (15–20 dəq).
4. EDS olduqda sürücülük məhdudlaşdırılmalıdır.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Natrium oksibat (Xyrem/Xywav) — qamma-hidroksibutirat (GHB); gecə 2 dozada verilir; katapleksiya və EDS-ə təsir.
2. Modafinil/Armodafinil — EDS üçün birinci sıra.
3. Pitolisant — H3 reseptor antaqonisti; EDS və katapleksiya.
4. Katapleksiya üçün SSGİ/SNGİ (venlafaksin, fluoksetin) təsdiqlənməmiş göstərişlə istifadə olunur.
5. MSLT-də SOREMP ≥ 2 olduqda diaqnoz təsdiqlənir.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM Treatment Guidelines (Maski 2021).
- FDA təsdiqləri — pitolisant 2019, solriamfetol 2019, Xywav 2020.

9. Proqnoz

- Xronik; farmakoterapiya ilə funksional yaxşılaşma.
- Komorbidlik (TDP, YAPP) müdaxiləsi vacib.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Narkolepsiya yalnız gündüz yuxululuğundan ibarətdir»

Sübut: tetrada (EDS + katapleksiya + paraliz + hallüsinasiya); MSLT-də SOREMP fərqləndirici.

Mif 2: «Katapleksiya tutmadır»

Sübut: Şüur saxlanılır; EEQ-də epileptik aktivlik aşkar edilmir; tetikləyici amil emosional xarakter daşıyır.

Mif 3: «H1N1 peyvəndi narkolepsiya yaradır — peyvəndlərdən qaçınmaq lazımdır»

Sübut: risk yalnız Pandemrix peyvəndi ilə (Skandinaviya, 2009) göstərilmişdir; başqa peyvəndlər təhlükəsizdir; ümumi peyvənddən qaçınma tövsiyə edilmir.

Mif 4: «Pasiyent sürücülük edə bilər»

Sübut: Narkolepsiyalı və EDS olan pasientdə sürücülük məhdudlaşdırılmalıdır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 7A20 Narkolepsiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnlə yenidən işlənmiş variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Maski K. və b. AASM Klinik Təcrübə Təlimatı. «Yuxu Tibbi Jurnalı» (J Clin Sleep Med). 2021;17(9):1881–1893.
4. Miller E. və b. AS03 adyuvantlı pandemik A/H1N1 2009 qrip vaksini alan uşaqlarda və gənclərdə narkolepsiya riski. «Britaniya Tibb Jurnalı» (BMJ). 2013;346:f794.
5. Mignot E. və b. Narkolepsiyanın diaqnostikasında serebrospinal mayedə hipokretinin ölçülməsinin rolu. «Ümumi Nevrologiya Arxivləri» (Arch Neurol). 2002;59(10):1553–1562.

XBT-11 **7A41**	**7A41 OBSTRUKTİV YUXU APNOESİ** **Obstructive sleep apnoea**
XBT-10 G47.3	Yuxu apnoesi
DSM-5-TR G47.33	Obstruktiv yuxu apnoesi/hipopnoesi

1. Tərif və nozologiya

Obstruktiv Yuxu Apnoesi (YAPP; XBT-11: 7A41; DSM-5-TR: G47.33) — yuxu zamanı təkrarlanan üst tənəffüs yolunun tam (apnoe) və ya qismən (hypopnea) tıxanması; gündüz yuxululuğu, koqnitiv pozulma, kardiovaskulyar mortalitenin artması.

2. Tarixçə

- Gastaut H. (1965) — YAPP klassik təsviri.

- Sallivan C.E. (1981) — davamlı müsbət təzyiqli hava yolu terapiyası (CPAP) üsulunu işləyib hazırlamışdır.
- AASM Practice Parameters (yenilənmə).

3. Epidemiologiya

- Yetkin əhalidə: kişilərdə təxminən 13%, qadınlarda təxminən 6% (orta-ağır YAPP).
- Yaşla, BKİ ilə artır.
- Komorbidlik: hipertenziya (50%), kardiovaskulyar, insult, atriyal fibrilyasiya, diabet.

4. Etiologiya və patogenez

- Anatomik — yağ toxuması üst hava yolunda, kiçik mandibula, böyümüş badamcıqlar/adenoidlər.
- Genetik meyillilik və ailə tarixçəsi.
- Bədən mövqeyi — sırtüstü vəziyyətdə pisləşir.
- Alkoqol və sedativ dərmanlar vəziyyəti pisləşdirir.

5. Klinik təzahürlər

- Yüksək xoruldama, müşahidə olunan apnoe, boğulma hissi ilə oyanma.
- Gündüz yuxululuğu (sürücülük zamanı təhlükəli), yorğunluq.
- Səhər baş ağrısı, ağızda quruluq.
- Diqqətin toplanması və yaddaş problemləri.
- Cinsi disfunksiya, depressiv simptomlar.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

Polisomnoqrafiya (PSG) — AHİ (apnoe-hipopnoe indeksi) ≥ 5/saat + simptomlar; AHI ≥ 15 AHİ ≥ 15 olduqda simptomlardan asılı olmayaraq.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing (2017).
- ev şəraitində yuxu apnoesi testi (HSAT) — orta-ağır YAPP-da uyğun.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. STOP-BANG skrininq (xoruldama, yorğunluq, müşahidə olunan apnoe, arterial təzyiq, bədən kütləsi indeksi, yaş, boyun ətrafı, cins).
2. Epvort yuxululuq şkalası (ESS).
3. Polisomnoqrafiya və ya HSAT.
4. Kardiovaskulyar qiymətləndirmə.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
İnsomniya (7A00)	Yatma və saxlama problemləri; xoruldama müşahidə olunmur.
Sentral yuxu apnoesi	Respirator səy yoxdur.
Narkolepsiya (7A20)	Katapleksiya, MSLT.
RLS	Ayaq narahatlığı.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- STOP-BANG, Epworth.
- PSG və ya HSAT.
- BKİ və boyun ətrafının ölçülməsi.

8. Müalicə

1. CPAP — Continuous Positive Airway Pressure birinci sıra orta-ağır YAPP üçün; AHI əhəmiyyətli azaldır; kardiovaskulyar mortalitetə təsiri randomizə sınaqlarda (SAVE, NEJM 2016) təsdiqlənməyib.
2. BiPAP — refrakter halda və ya CPAP cavabsız.
3. Çəkinin azaldılması — yüngül YAPP-da; bariatrik cərrahiyə ağır piylənmədə.
4. Alt çənəni irəli çəkən cihaz (MAD) — yüngül-orta YAPP, CPAP cavabsız.
5. Postural terapiya — sırtüstü vəziyyətdən qaçınma.
6. Cərrahiyə (UPPP, hipoqlossus sinirinin stimullaşdırılması — Inspire) — seçici hallarda.
7. Alkohol və sedativdən imtina.

8.1 Müalicə metodikaları

1. CPAP — Birinci sıra; müalicəyə əməl etmə əsas problemdir.
2. Alt çənəni irəli çəkən cihaz (MAD — mandibular advancement device) (MAD — Mandibular Advancement Device) — Yüngül-orta YAPP; CPAP-a cavab verm ədikdə.
3. Hipoqlossus sinirinin stimullaşdırılması (Inspire) — Yeni cərrahi seçenək; seçilmiş halda.
4. STOP-BANG, Epworth, PSG — Skrininq və diaqnostika.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM-ə görə CPAP standart metod, MAD isə seçici metoddur.
- NICE NG202 (YAPP-COPD-overlap).

9. Proqnoz

- CPAP simptomları və AHİ-ni etibarlı şəkildə azaldır, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır; kardiovaskulyar mortalitetə təsiri sübut olunmayıb (müşahidə tədqiqatları — Marin 2005 — əlaqələndirsə də, randomizə edilmiş sınaqlar — SAVE, NEJM 2016 — təsdiqləməyib, ehtimal ki, sınaqlarda müalicəyə əməl etmənin aşağı olması səbəbindən).
- Müalicəsiz — insult, atrial fibrilyasiya, diabet mortalitet artımı.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «YAPP yalnız obez insanlarda olur»

Sübut: normal çəkili pasiyentlərdə də mümkündür (anatomik amillər).

Mif 2: «Xoruldama YAPP-nın əsas əlamətidir, daha çox heç nə tələb etmir»

Sübut: xoruldama tək sübut deyil; AHI ölçüsü tələb olunur; YAPP müalicəsiz mortalitet və morbidlik yüksək.

Mif 3: «CPAP yalnız simptomları azaldır, mortalitetə təsir etmir»

Sübut: məsələ daha mürəkkəbdir. Müşahidə məlumatları (Marin Lancet 2005) mortalitet azalması ilə əlaqələndirilmişdir, lakin sonrakı randomizə sınaqlar (SAVE, NEJM 2016) kardiovaskulyar mortalitet azalmasını təsdiqləməyib — ehtimal ki, sınaqlarda aşağı komplayans (orta təxminən 3,3 saat/gecə, tövsiyə olunan təxminən 4 saatdan az) səbəbindən. CPAP simptomları, AHI-ni etibarlı azaldır və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır; mortalitetə təsiri sübut olunmamış qalır.

Mif 4: «Sentral yuxu apnoesi və YAPP eyni müalicə olunur»

Sübut: fərqli müdaxilə ((ASV — adaptiv servo-ventilyasiya; sentral apnoedə tətbiq olunur); diferensiasiya həlledicidir.); diferensiasiya kritikdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 7A41 Obstruktiv yuxu apnoesi. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnlə yenidən işlənmiş variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Kapur V.K. və b. Yetkinlərdə obstruktiv yuxu apnoesinin diaqnostik testlənməsi üzrə AASM Klinik Təcrübə Təlimatı. «Yuxu Tibbi Jurnalı» (J Clin Sleep Med). 2017;13(3):479–504.
4. Marin C.M. və b. CPAP müalicəsi ilə və ya müalicəsiz obstruktiv yuxu apnoesi-hipopnoesi olan kişilərdə uzunmüddətli ürək-damar nəticələri. «Lancet». 2005;365(9464):1046–1053.

XBT-11 **7A60–7A65**	**7A60–7A65 GECİKMİŞ TİPLİ YUXU-OYANIQLIQ FAZALARIN POZUNTUSU** **Circadian rhythm sleep-wake disorders**
XBT-10 F51.2	Yuxu və oyanıqlıq rejiminin qeyri-üzvi etiologiyalı pozuntuları
DSM-5-TR G47.21	DSM-5-TR / G47.21–G47.26 || Sirkadian ritm yuxu-oyanıqlıq pozuntuları (gecikmiş, erkən, nizamsız, 24 saatlıq olmayan tiplər, növbəli iş və saat qurşağı dəyişməsi tipləri)

1. Tərif və nozologiya

Sirkadian ritm yuxu-oyanıqlıq pozuntuları (XBT-11: 7A60–7A6Z; DSM-5-TR: G47.21–G47.26) — daxili sirkadian ritm ilə xarici sosial və işıq cədvəli arasında uyğunsuzluq; nəticədə insomniya və ya yuxululuq.

Alt tiplər:: Alt tiplər: gecikmiş yuxu-oyanma fazası pozuntusu (DSWPD), erkən yuxu-oyanma fazası pozuntusu, nizamsız yuxu-oyanıqlıq ritmi, 24 saatlıq olmayan yuxu-oyanıqlıq ritmi (kor insanlarda), növbəli iş pozuntusu, saat qurşağı dəyişməsi pozuntusu., Non-24-hour Sleep-Wake (kor insanlarda), Shift Work Disorder, Jet Lag Disorder.

2. Tarixçə

- 1960-cı illərdə Aschoff J. — sirkadian biologiya əsasları.
- AASM (2015) — sirkadian ritm pozuntuları üçün sirkadian ritm pozuntuları üzrə klinik təlimat.

3. Epidemiologiya

- DSWPD — yeniyetmələr və gənc yetkinlərdə 7–16%.
- Növbəli iş pozuntusu — Növbəli iş pozuntusu növbəli işləyənlərin 10–30%-də müşahidə olunur.
- Komorbidlik: TDP, narahatlıq, bipolyar, kardiovaskulyar.

4. Etiologiya və patogenez

- Endogen sirkadian ritm pozulması (saat genlərinin mutasiyaları nadir hallarda — ailəvi erkən yuxu fazası sindromu (familial advanced sleep phase)).
- Mühit — işıq ekspozisiyası, sosial cədvəl.
- Yeniyetmələrdə DSWPD — pubertat dövrünün hormonal dəyişiklikləri.

5. Klinik təzahürlər

- DSWPD — yuxu və oyanma vaxtının gec olması; məktəb/iş ilə uyğunsuzluq; «gecə quşu» (night owl) tips.
- Advanced — yuxu və oyanma vaxtının erkən olması; yaşlılarda.
- Nizamsız ritm — yuxu epizodları gün ərzinə səpələnmiş; demensiya və intellektual pozuntularda.

- Non-24-hour — kor insanlarda; sirkadian ritm xarici işıq siqnalına uyğunlaşmır.
- Shift Work — növbəli iş; insomniya + gündüz yuxululuğu.
- Saat qurşağı dəyişməsi (jet lag) — keçici vəziyyətdir.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Yuxu-oyanma cədvəli ilə daxili sirkadian ritm arasında uyğunsuzluq.

B. İnsomniya, yuxululuq və ya hər ikisi.

C. Müddət ≥ 3 ay (saat qurşağı dəyişməsi və növbəli iş pozuntusu istisna olmaqla).

D. Funksional pozulma.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM 2015 Clinical Practice Guideline.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə + yuxu gündəliyi 1–2 həftə.
2. Aktiqrafiya 2 həftə ərzində aparılır.
3. zəif işıqda melatonin başlanğıcı (DLMO) — tədqiqat kontekstində.
4. Komorbid yuxu pozuntularının istisnası.

6.4 Differensial diaqnostika

İnsomniya, YAPP, depressiv pozuntu, narkolepsiya.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Yuxu gündəliyi, aktiqrafiya.
- Münhen xronotip anketi (MCTQ).

8. Müalicə

1. Parlaq işıq terapiyası (bright light) — DSWPD-də səhər; erkən fazalı tipdə isə axşam.
2. Eksogen melatonin — fizioloji aşağı doza (0,3–5 mq); DSWPD-də axşam (vaxt kritik); jet lag-da.
3. Kronoterapiya — yuxu vaxtının tədricən sürüşdürülməsi.

4. Yuxu gigiyenası və davranış müdaxiləsi.
5. Növbəli iş — strategik dincəlmə, qaranlıq otaq, kafein qəbulunun vaxtının seçilməsi.
6. 24 saatlıq olmayan yuxu-oyanıqlıq ritmi pozuntusu olan kor pasiyentlərdə — tasimelteon (Hetlioz; ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA) tərəfindən təsdiqlənib).

8.1 Müalicə metodikaları

1. Parlaq işıq terapiyası (ing. bright light therapy) — 10 000 lüks, 30–60 dəqiqə; müddət sirkadian fərqinə uyğun seçilir.
2. Melatonin (Sirkadian) — Aşağı doza; vaxt kritik.
3. Aktiqrafiya (Actigraphy) — 2 həftə.
4. Tasimelteon — Non-24-hour üçün FDA təsdiqi.

9. Proqnoz

Müdaxilə ilə əksər pasiyent yaxşılaşır; xroniki formada davamlı strategiya tələb olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Yeniyetmə „tənbəldir“, erkən qalxa bilər»

Sirkadian ritmin gecikməsi pozuntusu (ing. delayed sleep-wake phase disorder, DSWPD) pubertat dövründə sirkadian gecikmənin neyrobioloji əsasına malikdir.

Mif 2: «Melatonin yuxu dərmanıdır»

Sübut: melatonin sirkadian fazasını tənzimləyir, hipnotik effekti minimaldır; vaxt seçimi kritik.

Mif 3: «Növbəli iş insomniyasının müalicəsi yoxdur»

Sübut: Strateji yuxu planlaması, işıq terapiyası, melatoninin düzgün vaxtda qəbulu və kafein istifadəsinin tənzimlənməsi vəziyyəti yaxşılaşdırır.

Mif 4: «Vaxt qurşağı dəyişməsi (ing. jet lag) öz-özünə keçib gedər»

Sübut: Hər 1 saatlıq vaxt qurşağı dəyişməsi üçün adaptasiya təxminən 1 gün çəkir; uyğunlaşmanı işıq terapiyası və melatonin sürətləndirir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 7A60–7A65 Sirkadian ritm yuxu-oyanıqlıq pozuntuları. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnlə yenidən işlənmiş variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Auger R.R. və b. Daxili sirkadian ritm yuxu-oyanıqlıq pozuntularının müalicəsi üzrə AASM Klinik Təcrübə Təlimatı. «Yuxu Tibbi Jurnalı» (J Clin Sleep Med). 2015;11(10):1199–1236.

XBT-11 **7A21–7A26**	**7A21–7A26 İDİOPATİK HİPERSOMNİYA** **Hypersomnolence disorders**
XBT-10 F51.1	Qeyri-üzvi etiologiyalı yuxululuq (hipersomniya)
DSM-5-TR F51.11	Hipersomnolens pozuntu

1. Tərif və nozologiya

Hipersomniya (ing. XBT-11: 7A21–7A26; DSM-5-TR: F51.11 Hypersomnolence Disorder) — gündüz həddindən artıq yuxululuq və ya yuxu epizodları (gecə 7 saatdan çox yuxudan sonra) müşahidə olunur və funksional pozulma yaradır. Bu pozuntular idiopatik hipersomniya, narkolepsiya və digər yuxu pozuntularından differensial diaqnostika yolu ilə ayırd edilir.

2. Tarixçə

1970–80-ci illərdə narkolepsiya ilə differensiasiya inkişaf etdi; AASM klinik göstərişləri.

3. Epidemiologiya

- İdiopatik hipersomniya: təxminən 50/100 000.
- Kleine-Levin sindromu — nadir (təxminən 1/1 mln); təkrarlanan hipersomniya epizodları + iştah/cinsi pozulma.
- Komorbidlik: depressiv simptomlar, YAPP, narkolepsiya.

4. Etiologiya və patogenez

- Naməlum (idiopatik) — neyrobioloji dizregulyasiya hipotezi.
- İdiopatik hipersomniyada GABA-ergik sistemin dizregulyasiyası müşahidə olunur.
- İkincili — Kleine-Levin (autoimmun şübhəsi), TBI sonrası, MS, depressiv pozuntu.

5. Klinik təzahürlər

- Davamlı gündüz yuxululuğu (ing. excessive daytime sleepiness — həddindən artıq gündüz yuxululuğu).
- Uzun gecə yuxusu (≥ 9 saat) kifayət etmir.
- «Yuxu sərxoşluğu» (ing. sleep drunkenness) — oyandıqdan sonra şüur qarışıqlığı və dezorientasiya müşahidə olunur.
- Gündüz yuxuları uzun və bərpaetməyən xarakter daşıyır (narkolepsiyada isə qısa və bərpaedicidir).
- Kleine-Levin — 1–2 həftəlik hipersomniya epizodları, hiperfagiya və dezinfibisiya davranışı ilə müşayiət olunur.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar

A. Yetərli yuxudan (≥ 7 saat) sonra həddindən artıq yuxululuq və ya uzun yuxu müşahidə olunur.

B. Tezlik və müddət — həftədə ≥ 3 dəfə, ≥ 3 ay.

C. Əhəmiyyətli əzab-əziyyət və ya funksional pozulma.

D. Başqa yuxu pozuntusu, maddə istifadəsi və ya tibbi vəziyyət ilə tam izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM (Amerika Yuxu Tibbi Akademiyası) təcrübi tövsiyələri — diaqnostik polisomnografiya (PSG) və Çoxsaylı Yuxu Latentliyi Testi (MSLT).
- İdiopatik hipersomniya — MSLT-də orta yuxu latentliyi ≤ 8 dəqiqə; yuxu başlanğıcında REM dövrü (SOREMP) ≤ 1 (narkolepsiyadan fərqli).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə və yuxu gündəliyi.
2. Epworth Sleepiness Scale.
3. PSG + MSLT (narkolepsiya istisnası).
4. Tibbi qiymətləndirmə — tiroid, anemiya, depressiv, YAPP.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Narkolepsiya (7A20)	Katapleksiya, SOREMP ≥ 2.
YAPP (7A41)	Xoruldama, AHI ↑.
Depressiv pozuntu	Affektiv simptomlar.
İnsomniya (7A00)	Yetərsiz yuxu.
Kleine-Levin sindromu	Epizodik 1–2 həftəlik hipersomniya və iştahanın artması.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Epworth, PSG + MSLT.
- Tibbi laboratoriya müayinələri aparılır.

8. Müalicə

1. Modafinil və armodafinil birinci sıra preparatlarıdır.
2. Stimulyantlar (metilfenidat, amfetamin) — refrakter.
3. Aşağı natriumlu oksibat (Xywav, FDA 2021) — idiopatik hipersomniyada təsdiqlənmiş yeganə preparat.
4. Pitolisant (FDA 2019) — narkolepsiyada; solriamfetol (FDA 2019) — narkolepsiya və obstruktiv yuxu apnoesində təsdiqlənib; idiopatik hipersomniyada hər ikisi təsdiqlənməmiş göstərişlə istifadə olunur.
5. Yuxu hijyeni və davranış müdaxiləsi (planlaşdırılmış gündüz yuxular).
6. Kleine-Levin sindromunda dəstəkləyici müalicə tətbiq edilir; epizodlar arası dövrdə simptomlar olmur.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Modafinil/Armodafinil — Oyaqlığı artıran preparatlar; birinci sıra; baş ağrısı və narahatlıq yan təsirləri müşahidə olunur.

2. Çoxsaylı Yuxu Latentliyi Testi (MSLT — Multiple Sleep Latency Test) — 5 yuxu cəhdi 2 saat fasilə ilə aparılır; yuxu latentliyinin ölçülməsi həyata keçirilir.
3. Pitolisant və solriamfetol yeni preparatlar olub refrakter hallarda tətbiq edilir.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AASM Treatment Guidelines (Maski K. və b. 2021).

9. Proqnoz

Xəstəlik xronik gedişlidir; farmakoterapiya fonunda funksional yaxşılaşma müşahidə olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Gündüz yuxululuğu „tənbəllik“dir»

Sübut: bu, klinik vəziyyətdir; mortalitet və qəza riski artır.

Mif 2: «Kafein hipersomniya üçün kifayətdir»

Sübut: kafein köməkçi vasitədir; modafinil və ya stimulyant tələb olunur.

Mif 3: «Hipersomniya yalnız depressiya əlamətidir»

Sübut: idiopatik hipersomniya ayrı pozuntudur; MSLT differensial diaqnostika aparmağa imkan verir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). 7A21–7A26 Hipersomnolentlik pozuntuları. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnlə yenidən işlənmiş variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Maski K. və b. Mərkəzi hipersomnolentlik pozuntularının müalicəsi: AASM Klinik Təcrübə Təlimatı. «Yuxu Tibbi Jurnalı» (J Clin Sleep Med). 2021;17(9):1881–1893.

HA00–HA0Z CİNSİ SAĞLAMLIQ

Cinsi sağlamlıqla əlaqəli vəziyyətlər (ing. conditions related to sexual health)

XBT-11 **HA01.1**	**HA01.1 KİŞİ EREKTİL DİSFUNKSİYASI** **Male erectile dysfunction**
XBT-10 F52.2	Genital reaksiyanın çatışmamazlığı
DSM-5-TR F52.21	Erektil disfunksiya

1. Tərif və nozologiya

Erektil Disfunksiya (ing. ED; XBT-11: HA01.1 Erectile Dysfunction; DSM-5-TR: F52.21) — cinsi əlaqə üçün kifayət edən ereksiyanı əldə etmədə və ya saxlamaqda davamlı çətinlik. Pozuntu ən azı 6 ay ərzində, əksər cəhdlərdə müşahidə olunur.

2. Tarixçə

- 1998 — sildenafilin (Viagra) ABŞ Qida və Dərman İdarəsi (FDA) tərəfindən təsdiqi erektil disfunksiyanın müalicəsində mühüm mərhələ olmuşdur.
- AUA (Amerika Uroloji Assosiasiyası) təlimatı (Burnett A.L. və həmk., 2018; 2024-cü il yenilənməsi).
- EAU (Avropa Uroloji Assosiasiyası) təlimatları.

3. Epidemiologiya

- 40 yaşında 5–10%, 70 yaşında 50%-dən çox (mənbə göstərilməklə).
- Risk amilləri: diabet, kardiovaskulyar xəstəlik (ED kardiovaskulyar xəstəliyin erkən markeri kimi), hipertenziya, hiperlipidemiya, siqaret, piylənmə, depressiya, antidepressantlar.

4. Etiologiya və patogenez

- Orqanik (təxminən 70%) — vaskulyar, neyrogen, endokrin (hipoqonadizm), dərmana bağlı.

- Psixogen (təxminən 10%) — performans narahatlığı, münasibət problemləri, depressiya.
- Qarışıq (təxminən 20%).
- Princeton III Consensus (Nehra 2012) — ED kardiovaskulyar erkən marker, kardial risk qiymətləndirməsi vacib.

5. Klinik təzahürlər

- Ereksiya əldə etmə və ya saxlama çətinliyi.
- Səhər və ya gecə ereksiyalarının olub-olmaması (psixogen və orqanik səbəbləri ayırd etmək üçün).
- Münasibət və emosional yük.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (AUA 2018, EAU)

A. Ereksiyanı əldə etmədə və ya saxlamaqda davamlı çətinlik.

B. Müddət ≥ 6 ay, əksər cəhdlərdə.

C. Əzab-əziyyət və ya münasibət pozulması.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- AUA 2018/2024 və EAU — pillə-pillə yanaşma.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (cinsi və tibbi tarixçə, münasibətlər).
2. Beynəlxalq Erektil Funksiya İndeksi (IIEF) və Kişilər üçün Cinsi Sağlamlıq Sorğusu (SHIM).
3. Laborator — səhər testosteronu, qlükoza, HbA1c, lipid, prolaktin, tiroid.
4. Kardiovaskulyar qiymətləndirmə.
5. Penil exoqrafiya (vaskulyar pozuntu şübhəsi olduqda) — seçilmiş hallarda.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Hipoqonadizm	Testosteron aşağı + simptomlar.
Erkən eyakulyasiya (HA03)	Eyakulyasiya vaxtı.

Vəziyyət	Fərqləndirici
HSDD	İstək azalması dominant.
Peyronie xəstəliyi	Penil əyrilik və ağrı.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- IIEF.
- Tibbi və laborator (yuxarıda).
- Kardial qiymətləndirmə (zərurət olduqda EKQ və stress testi).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (AUA 2018/2024, EAU pillə-pillə)

1. 1-ci sıra:
    - Həyat tərzi — siqaretdən imtina, çəki, fiziki aktivlik, kardiovaskulyar riskin idarə edilməsi;
    - FDE5 (fosfodiesteraza-5) inhibitorları — sildenafil (25–100 mq), tadalafil (5–20 mq lazım olduqda və ya 2,5–5 mq gündəlik), vardenafil, avanafil; nitratla mütləq əks-göstərişdir; α-blokatorla ehtiyat.
2. 1-ci sıra (hipoqonadizmdə): testosteron əvəzedici terapiya (TƏT) — yalnız təsdiqlənmiş hipoqonadizmdə (ardıcıl 2 səhər ölçmədə aşağı səviyyə və simptomlar); prostat-spesifik antigen (PSA) və hematokrit göstəricilərinə nəzarət.
3. 2-ci sıra:
    - İntrakavernozal alprostadil (PGE1);
    - İntrauretral alprostadil (MUSE);
    - Vakuum erektil cihaz.
4. 3-cü sıra: penil protez (yarımsərt və ya şişirdilə bilən); yüksək məmnunluq.
5. Psixoterapiya — performans narahatlığında; cütlük terapiyası.
6. Antidepressant induksiyalı ED — bupropion, mirtazapin, vortioksetin alternativ; sildenafil köməkçi vasitə kimi (Nurnberg və həmk., JAMA, 2003).

8.2 Müalicə metodikaları

1. FDE5 inhibitorları — fosfodiesteraza-5 inhibitorları; nitratlarla mütləq əks-göstərişdir.

2. İntrakavernozal Alprostadil — PGE1; PDE5 cavabsızlıqda.
3. Vakuum cihazı (ing. vacuum device) — qeyri-invaziv metod; antikoaqulyant qəbul edən pasientlərdə istifadə oluna bilər.
4. Penil Protez (ing. Penile Prosthesis) — Refrakter ED; yüksək məmnuniyyət.
5. Beynəlxalq Erektil Funksiya İndeksi (ing. International Index of Erectile Function, IIEF) — Şiddət şkalası.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- Burnett A.L. və b. AUA Guideline. J Urol 2018, 2024 yenilənmə.
- Salonia A. və b. EAU Guidelines 2023.

9. Proqnoz

PDE5 ilə 70% effektivlik; refrakter halda 2–3-cü sıra; kardiovaskulyar riskin idarə edilməsi mortaliteti azaldır.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «ED qocalmanın təbii təzahürüdür və müalicə tələb etmir»

Sübut: ED kardiovaskulyar erkən marker; aktiv müdaxilə vacib.

Mif 2: «Reseptsiz „təbii“ potensiya gücləndiriciləri təhlükəsizdir»

Sübut: FDA xəbərdarlıqları — bir çox «təbii» preparatın tərkibində bəyan edilməmiş sildenafil və ya tadalafil — nitratla qarşılıqlı təsir, ölüm riski.

Mif 3: «Testosteron əvəzedici terapiya hər ED pasiyenti üçün lazımdır»

Sübut: AUA — yalnız təsdiqlənmiş hipoqonadizmdə; rutin TRT tövsiyə edilmir.

Mif 4: «Aşağı intensivlikli şok dalğa terapiyası (Li-ESWT) standart müalicədir»

Sübut: AUA 2024 — tədqiqat mərhələsindədir; standart birinci sıra müalicəsi deyil.

Mif 5: «Yohimbin effektiv təbii alternativdir»

Sübut: Ernst E., Pittler M.H. J Urol 1998;159(2):433–436 — kiçik effekt, narahatlıq və hipertenziya yan təsirləri; PDE5 üstün.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). HA01.1 Kişilərdə erektil disfunksiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnlə yenidən işlənmiş variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Burnett A.L. və b. Erektil disfunksiya: AUA Təlimatı. «Urologiya Jurnalı» (J Urol). 2018;200(3):633–641.
4. Salonia A. və b. Cinsi və Reproduktiv Sağlamlıq üzrə EAU Təlimatları 2023.
5. Nehra A. və b. Erektil disfunksiya və ürək-damar xəstəliklərinin idarə edilməsi üzrə Prinston III Konsensus tövsiyələri. «Mayo Klinika Materialları» (Mayo Clin Proc). 2012;87(8):766–778.
6. Yuan C. və b. Erektil disfunksiyada oral fosfodiesteraza tip 5 inhibitorlarının müqayisəli effektivliyi və təhlükəsizliyi: sistematik icmal və şəbəkə meta-analizi. «Avropa Urologiyası» (Eur Urol). 2013;63(5):902–912.

XBT-11 **HA03.0**	**HA03.0 KİŞİLƏRDƏ ERKƏN EYAKULYASİYA** **Male early ejaculation**
XBT-10 F52.4	Vaxtından qabaq eyakulyasiya
DSM-5-TR F52.4	Erkən eyakulyasiya

1. Tərif və nozologiya

Erkən eyakulyasiya (EE; XBT-11: HA03.0; DSM-5-TR: F52.4) — eyakulyasiyanın istənmədən qısa müddət ərzində, çox vaxt penetrasiyadan əvvəl və ya təxminən 1 dəq içində baş verməsi; nəzarət itkisi və əzab-əziyyət.

Alt tiplər: ömürlük (ilkin) — başlanğıcdan; qazanılmış (ikincili) — sonradan inkişaf etmiş; dəyişkən və subyektiv — ISSM (Beynəlxalq Cinsi Tibb Cəmiyyəti) təsnifatı.

2. Tarixçə

- Semans J.H. (1956) — «dayan-başla» (ing. start-stop) texnikası.
- Masters və Conson (1970) — «sıxma» (ing. squeeze) davranış metodu.
- ISSM (Beynəlxalq Cinsi Tibb Cəmiyyəti) 2014-cü ildə Althof S.E. və həmk. tərəfindən hazırlanmış beynəlxalq diaqnostik və müalicə təlimatını dərc etmişdir.
- 2009 — dapoxetin Avropa İttifaqında (Aİ) erkən eyakulyasiya üçün təsdiqlənmiş ilk preparat olmuşdur.

3. Epidemiologiya

- Kişilərdə yayılma 20–30% (öz-özünə bildirilən); ISSM meyarlarına ciddi uyğunluqla 4–5%.
- Yaşla əlaqəli dəyişkənlik azdır; pozuntu bütün yaş qruplarında rast gəlinir.
- Komorbidlik: ED, narahatlıq, depressiya, münasibət gərginliyi.

4. Etiologiya və patogenez

- Neyrobioloji — serotoninergik (5-HT2C, 5-HT1A balansı); genetik komponent (ömürlük forma).
- Psixoloji — performans narahatlığı, erkən cinsi təcrübə, münasibət problemləri.
- Qazanılmış forma — erektil disfunksiya, prostatit, hipertiroidizm, narkotik maddə istifadəsi.

5. Klinik təzahürlər

- İntravaginal eyakulyasiya gecikmə vaxtı (IELT) qısa (lifelong təxminən 1 dəq; acquired ≤ 3 dəq).
- Nəzarət itkisi.
- Əzab-əziyyət, qaçınma, münasibət gərginliyi.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (ISSM 2014, DSM-5-TR)

A. Eyakulyasiya həmişə və ya demək olar ki, həmişə penetrasiyadan əvvəl və ya təxminən 1 dəq içində (lifelong) və ya gecikmə vaxtının ≤ 3 dəqiqəyə qədər klinik mənalı azalması (qazanılmış forma).

B. Bütün və ya demək olar ki, bütün penetrasiyalarda eyakulyasiyanı gecikdirə bilməmə.

C. Mənfi şəxsi nəticələr — əzab-əziyyət, qaçınma.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ISSM (Althof S.E. və b. J Sex Med 2014).
- AUA və EAU təlimatları.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (cinsi tarixçə, IELT, nəzarət, əzab-əziyyət).
2. Erkən eyakulyasiya diaqnostika aləti (PEDT) — 5 bəndlik sorğu.
3. Komorbid ED qiymətləndirməsi (IIEF).
4. Endokrin və uroloji müayinə (acquired forma).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
ED (HA01)	Ereksiyanı saxlama çətinliyi.
Variable PE	Klinik vahid deyil — normal variasiya.
Subjective PE	IELT normal, lakin qavrayış pozulması.
Prostatit	Çanaq ağrısı; acquired PE.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- PEDT, IIEF.
- IELT (xronometraj — tövsiyə edilərkən).
- Endokrin və uroloji müayinə (acquired şübhəsi).

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (ISSM 2014, AUA, EAU)

1. Davranış metodları (1-ci sıra və ya kombinasiya):
    - «Dayan-başla» metodu (Semans);
    - «Sıxma» (squeeze) metodu (Masters və Conson);
    - Çanaq dibi əzələlərinin məşqləri (Pastore A. və həmk. randomizə edilmiş klinik tədqiqat, 2014).

2. Dapoxetin — qısa təsirli SSGİ; 30–60 mq cinsi əlaqədən 1–3 saat əvvəl qəbul edilir; Aİ-də və bir çox ölkədə erkən eyakulyasiya üçün təsdiqlənib; ABŞ-da FDA tərəfindən erkən eyakulyasiya üçün təsdiq edilməyib.
3. SSGİ-lərin gündəlik təsdiqlənməmiş istifadəsi — paroksetin (10–40 mq) ən yüksək effektivliyə malikdir (Waldinger və həmk. meta-analizi); sertralin, fluoksetin və sitalopram alternativ variantlardır; cinsi yan təsirlər mümkündür.
4. Topik anestetiklər — lidokain/prilokain (EMLA, TEMPE/Fortacin sprey) penetrasiyadan əvvəl (krem 20–30 dəq, sprey təxminən 5 dəq); cinsi tərəfdaşa keçmədən qorunma (kondom və ya silmə).
5. Tramadol — seçilmiş hallarda (asılılıq riski nəzərə alınmaqla).
6. FDE5 inhibitorları yalnız komorbid erektil disfunksiya olduqda tətbiq edilir.
7. Cütlük terapiyası və koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) — performans narahatlığı olduqda.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Dapoxetin — qısa təsirli SSGİ; zərurət olduqda istifadə olunur; Aİ-də təsdiqlənib.
2. Topik Anestetik — Lidocain/prilocain (EMLA krem 20–30 dəq; Fortacin sprey təxminən 5 dəq əvvəl).
3. SSGİ-lərin gündəlik istifadəsi (təsdiqlənməmiş göstərişlə) — paroksetin ən yüksək effektivliyə malikdir.
4. «Dayan-başla» və «sıxma» (squeeze) texnikaları — davranış metodları; tək və ya kombinasiyada tətbiq edilir.
5. Çanaq Dibi Əzələ Məşqləri (ing. Pelvic Floor Exercises) Pastore A. və həmk. (2014) — IELT-nin artması.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- Althof S.E. və b. ISSM Guideline. J Sex Med 2014.
- Waldinger M.D. və b. SSGİ meta-analiz.

9. Proqnoz

Dapoxetin və SSGİ ilə IELT 2–4 dəfə artır; davranış kombinasiyası uzunmüddətli effekti dəstəkləyir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «PE yalnız psixoloji problemdir»

Sübut: lifelong PE serotoninergik neyrobiologiya ilə bağlı; dapoxetin və SSGİ təsiri bunu təsdiqləyir.

Mif 2: «Dapoxetin ABŞ-da FDA tərəfindən təsdiqlənib»

Sübut: dapoxetin ABŞ FDA-da PE üçün təsdiq edilməyib; EU və bir çox ölkədə təsdiqli; ABŞ-da təsdiqlənməmiş göstərişlə gündəlik SSGİ ilə müalicə tətbiq olunur.

Mif 3: «Topik anestetik təhlükəsiz və partnyora təsirsizdir»

Sübut: kondom və ya silmə partnyora keçidən qorunma üçün vacib; əks halda tərəfdaş hissiyyatının azalması ilə üzləşə bilər.

Mif 4: «Reseptsiz „PE gücləndiriciləri“ təhlükəsizdir»

Sübut: FDA xəbərdarlıqları — bir çox «təbii» preparatın tərkibində bəyan edilməmiş SSGİ və ya anestetik komponentlər aşkar edilir.

Mif 5: «Davranış terapiyası yalnız köhnə metoddur»

Sübut: ISSM «dayan-başla», «sıxma» (squeeze) və çanaq dibi əzələlərinin məşqlərini tövsiyə edir; farmakoterapi ilə kombinasiyada effektivlik artır.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). HA03.0 Kişilərdə erkən boşalma. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnlə yenidən işlənmiş variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Althof S.E. və b. Erkən boşalmanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə Beynəlxalq Cinsi Tibb Cəmiyyətinin təlimatlarının yenilənməsi. «Cinsi Tibb Jurnalı» (J Sex Med). 2014;11(6):1392–1422.
4. Waldinger M.D. və b. Erkən boşalmanın dərman müalicəsinin effektivliyinin şərhində metodoloji dizaynın əhəmiyyəti: sistematik icmal və meta-analiz. «Beynəlxalq İmpotensiya Araşdırmaları Jurnalı» (Int J Impot Res). 2004;16(4):369–381.
5. Pastore A.L. və b. Ömürboyu erkən boşalması olan xəstələrdə çanaq dibi əzələlərinin reabilitasiyası: yeni terapevtik yanaşma. «Urologiyada Terapevtik İrəliləyişlər» (Ther Adv Urol). 2014;6(3):83–88.

XBT-11 **HA00**	**HA00 HİPOAKTİV CİNSİ İSTƏK DİSFUNKSİYASI** **Hypoactive sexual desire dysfunction**
XBT-10 F52.0	Cinsi meylin olmaması və ya itirilməsi
DSM-5-TR F52.0 / F52.22	Kişilərdə hipoaktiv cinsi istək pozuntusu / Qadınlarda cinsi istək/oyanma pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Hipoaktiv cinsi istək disfunksiyası (HSDD; XBT-11: HA00 XBT-11: HA00 hipoaktiv cinsi istək disfunksiyası (ing. Hypoactive sexual desire dysfunction); DSM-5-TR: qadınlarda cinsi istək/oyanma pozuntusu (ing. Female Sexual Interest/Arousal Disorder, F52.22), kişilərdə hipoaktiv cinsi istək pozuntusu (ing. Male Hypoactive Sexual Desire Disorder, F52.0)) — cinsi fantaziyalara və cinsi əlaqəyə olan istəyin davamlı azalması və ya yoxluğu; əzab-əziyyət ilə.

Müddət ≥ 6 ay; situativ və ya generalizə olunmuş; ömürboyu (lifelong) və ya qazanılmış (acquired).

2. Tarixçə

- Kaplan H.S. (1977) — Kaplan H.S. (1977) istək fazasını cinsi cavab modelinə daxil etmişdir.
- Basson R. (2000) — Basson R. (2000) qadınlarda dövri istək-həyəcan modelini təklif etmişdir.
- 2015-ci ildə flibanserin, 2019-cu ildə isə bremelanotid FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir.
- ISSWSH (ing. International Society for the Study of Women’s Sexual Health) Process of Care 2018 (Clayton A.H.).

3. Epidemiologiya

- Qadınlarda 8–10% distressle (HSDD); kişilərdə %14–17 müşahidə olunur.
- Yaşa bağlı artım; perimenopoz risk dövrü.

- Komorbidlik: depressiya, antidepresant istifadəsi (SSGİ), münasibət problemləri.

4. Etiologiya və patogenez

- Bioloji — hormonal (testosteron, östrogen), dərmana bağlı (SSGİ, oral kontraseptivlər, antihipertenziv dərmanlar), xroniki xəstəliklər.
- Psixoloji — depressiya, narahatlıq, bədən qavrayışı, cinsi travma tarixçəsi.
- Münasibət — münaqişə, partnyorun cinsi disfunksiyası.
- Sosial-mədəni — qadağa, məlumatsızlıq.

5. Klinik təzahürlər

- Spontan cinsi fantaziya və düşüncələrin azalması və ya yoxluğu.
- Cinsi yaxınlığa təşəbbüs göstərməmək və partnyorun təşəbbüsünə cavab verməmək.
- Əzab-əziyyət (kritik meyar — yalnız aşağı istək kifayət deyil).

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR, ISSWSH)

A. Cinsi fantaziya və istəyin davamlı azalması və ya yoxluğu.

B. Müddət ≥ 6 ay.

C. Klinik mənalı əzab-əziyyət.

D. Başqa psixi pozuntu, dərman və ya tibbi vəziyyət ilə daha yaxşı izah olunmur.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ISSWSH Process of Care (Clayton A.H. və b. Mayo Clin Proc 2018).
- DSM-5-TR qadınlarda cinsi istək/oyanma pozuntusu vahid kateqoriya kimi birləşdirilmişdir (FSIAD).

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (cinsi və münasibət tarixçəsi).
2. Azalmış cinsi istək skrininqi (ing. DSDS, Decreased Sexual Desire Screener) — qadınlar üçün 5 bəndlik anket.
3. Hormonal qiymətləndirmə (kişilərdə səhər saatlarında testosteron səviyyəsi; qadınlarda göstəriş olduqda).
4. Dərman və komorbidlik analizi.

5. Depressiya, narahatlıq skrininqi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Hipoqonadizm	Testosteron səviyyəsi aşağıdır və simptomlar müşahidə olunur.
Depressiv pozuntu	Anhedoniya, əhval pozuntusu.
SSGİ induksiyalı	Dərmana bağlı zaman.
Anorqazmiya (HA02.0)	Orqazm pozuntusu üstünlük təşkil edir.
Münasibət problemi	Situativ.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- DSDS, FSFI, IIEF.
- Hormonal panel.
- Depressiya/narahatlıq şkalaları.

8. Müalicə

8.1 Ümumi prinsiplər (ISSWSH 2018)

1. Bioloji-psixoloji-sosial yanaşma — etiologiyaya görə multimodal.
2. Psixoterapiya və cüt terapiyası — KDT, şüurlu fərqindəlik (ing. mindfulness), hissi fokus (ing. sensate focus) (Masters və Johnson).
3. Dərman dəyişikliyi — SSGİ induksiyalı halda bupropion, mirtazapin, vortioksetin alternativ variant kimi nəzərdən keçirilir.
4. Qadınlarda farmakoterapiya (premenopozal hipoaktiv cinsi istək pozuntusu):
    - Flibanserin (gecə vaxtı 100 mq) — FDA 2015 təsdiqi; alkoholla birlikdə ağır hipotenziya və senkop riski (FDA 2019 xüsusi xəbərdarlığı yeniləmişdir: 1–2 standart içkidən sonra ən azı 2 saat gözləmək, 3 və daha çox içki qəbul edildikdə həmin axşam dozanı buraxmaq lazımdır);
    - Bremelanotid (lazım olduqda 1,75 mq dərialtı) — FDA 2019 təsdiqi; melanokortin aqonisti.
5. Qadınlarda postmenopozal: transdermal testosteron aşağı dozada (rəsmi göstərişdən kənar, beynəlxalq konsensus, Davis S.R., 2019) — diqqətli izləmə tələb olunur.

6. Kişilərdə: hipoqonadizm təsdiqlənmiş halda TRT (≥ 2 səhər ölçüsü aşağı + simptomlar).
7. Münasibət və ünsiyyət işi kritik.

8.2 Müalicə metodikaları

1. Flibanserin serotonin 1A reseptorlarının aqonisti, 2A reseptorlarının isə antaqonistidir; gecə vaxtı gündəlik qəbul edilir; premenopozal qadınlarda istifadə olunur.
2. Bremelanotid — Melanocortin agonisti; s/c lazım olduqda.
3. Testosteron (qadınlarda, rəsmi göstərişdən kənar) — postmenopozal dövrdə aşağı dozada; monitorinq tələb olunur.
4. KDT və şüurlu fərqindəlik (ing. mindfulness) — Brotto L.A.-nın tədqiqatları — qadın cinsi disfunksiyasında effektiv.
5. Hissi fokus (ing. sensate focus) — cüt terapiyası texnikasıdır.

8.3 Mənbələr arasında fərqlər

- Clayton A.H. və b. ISSWSH Process of Care. Mayo Clin Proc 2018.
- Davis S.R. və b. Global Consensus Position Statement on Testosterone Therapy for Women. J Clin Endocrinol Metab 2019.

9. Proqnoz

Multimodal yanaşma ilə əksər pasiyentlər yaxşılaşır; xroniki formada davamlı strategiya tələb olunur.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Aşağı istək həmişə pozuntudur»

Sübut: əzab-əziyyət kritik meyar; əziyyət olmadan aşağı istək normal variasiya — patoloji deyil.

Mif 2: «Testosteron bütün qadınlar üçün istək gücləndiricisidir»

Sübut: Davis 2019 konsensus — yalnız postmenopozal hipoaktiv cinsi istək pozuntusunda aşağı doza off-label; bütün qadınlar üçün qəbulu rəsmi tövsiyə deyil.

Mif 3: «Flibanserin „qadın Viagrasıdır“»

Sübut: mexanizmi tamamilə fərqli (serotoninergik, mərkəzi sinir sistemi — MSS); gündəlik istifadə; təsiri mötədildir (sildenafil ilə müqayisə yanlış).

Mif 4: «İstək disfunksiyası yalnız psixoloji səbəbdəndir»

Sübut: SSGİ, OK, antihipertenzivlər və hormonal dəyişikliklər güclü təsir göstərir; bioloji axtarış vacib.

Mif 5: «Reseptsiz „afrodizyaklar“ effektivdir»

Sübut: Cochrane və sistematik icmallar — kiçik və ya yox effekt; FDA xəbərdarlıqları bəyan edilməmiş tərkib hissələrinə aiddir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (XBT-11). HA00 Hipaktiv cinsi istək disfunksiyası. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təlimatı, 5-ci nəşr, mətnlə yenidən işlənmiş variantı (DSM-5-TR). 2022.
3. Kleyton A.H. və b. Qadınların Cinsi Sağlamlığının Tədqiqi üzrə Beynəlxalq Cəmiyyətin (ISSWSH) qadınlarda hipoaktiv cinsi istək pozuntusunun (HSDD) idarə edilməsi üzrə qayğı prosesi. «Mayo Klinikasının Materialları» (Mayo Clin Proc). 2018;93(4):467–487.
4. Deyvis S.R. və b. Qadınlarda testosteron terapiyasının istifadəsi ilə bağlı Qlobal Konsensus Mövqe Bəyanatı. «Klinik Endokrinologiya və Metabolizm Jurnalı» (J Clin Endocrinol Metab). 2019;104(10):4660–4666.
5. Basson R. Qadın cinsi reaksiyası: fərqli model. «Cinsi və Nikah Terapiyası Jurnalı» (J Sex Marital Ther). 2000;26(1):51–65.
6. Brotto L.A. Mindfulnes vasitəsilə daha yaxşı cinsi həyat: qadınlar istəyi necə inkişaf etdirə bilər. Vankuver: Qreystoun Buks; 2018.

XBT-11 **HA02.0**	**HA02.0 ANORQAZMİYA** **Anorgasmia**
XBT-10 F52.3	Orqazm disfunksiyası
DSM-5-TR F52.31 / F52.32	Qadınlarda orqazm pozuntusu / gecikmiş eyakulyasiya

1. Tərif və nozologiya

Anorqazmiya (XBT-11: HA02.0 Anorgasmia; DSM-5-TR: qadınlarda orqazm pozuntusu (ing. Female Orgasmic Disorder, F52.31); kişilərdə gecikmiş eyakulyasiya (ing. Delayed Ejaculation, F52.32)) — kifayət edən cinsi həyəcandan sonra orqazma nail olma çətinliyi, gecikmə və ya yoxluğu; və ya orqazm intensivliyinin azalması.

Müddət ≥ 6 ay; situasion və ya generalizə olunmuş; ömürboyu (lifelong) və ya qazanılmış (acquired).

2. Tarixçə

- Masters və Johnson (1970) — Masters və Johnson (1970) orqazm fazasının pozuntusunu klassik şəkildə təsvir etmişlər.
- ISSWSH və ISSM göstərişləri.

3. Epidemiologiya

- Qadınlarda %5–10 klinik mənalı anorqazmiya; kişilərdə gecikmiş eyakulyasiya %1–4 tezliklə müşahidə olunur.
- Antidepresant (SSGİ) istifadəsində cinsi yan təsir %30–70 müşahidə olunur.

4. Etiologiya və patogenez

- Dərmana bağlı (SSGİ, antipsixotik, opioid).
- Neyroloji (çanaq nahiyəsində cərrahiyyə, multipel skleroz (MS), diabetik neyropatiya).
- Endokrin (hipotireoz, hiperprolaktinemiya).
- Psixoloji — narahatlıq, travma, bilik çatışmazlığı.
- Yaş və hormonal dəyişikliklər.

5. Klinik təzahürlər

- Orqazma çatma çətinliyi və ya yoxluğu.
- Orqazm intensivliyinin azalması.
- Əzab-əziyyət, qaçınma.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR)

A. Kifayət edən cinsi həyəcandan sonra orqazm gecikməsi, yoxluğu və ya intensivliyinin azalması — halların 75–100%-də.

B. Müddət ≥ 6 ay.

C. Əzab-əziyyət.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ISSM Delayed Ejaculation Guideline.
- ISSWSH qadınlarda orqazm disfunksiyası üzrə tövsiyələr vermişdir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (cinsi tarixçə, masturbasiya zamanı orqazm, partnyorla orqazm).
2. FSFI (qadınlarda) / IIEF (kişilərdə).
3. Dərman və komorbidlik təhlili.
4. Endokrin (testosteron, prolaktin, tiroid).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
HSDD (HA00)	İstək azalması dominant.
Retroqrad eyakulyasiya	Orqazm olur, lakin eyakulyat sidik kisəsinə boşalır.
SSGİ induksiyalı	Dərmana bağlı zaman.
Erektil disfunksiya (HA01.1)	Ereksiya pozuntusu.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- FSFI, IIEF.
- Hormonal panel.
- Neyroloji və uroloji müayinə (qazanılmış forma şübhəsi olduqda).

8. Müalicə

1. Etioloji yanaşma — dərman, endokrin və neyroloji səbəblərin aradan qaldırılması.
2. SSGİ induksiyalı anorgasmiya:
    - Dərman keçidi — bupropion, mirtazapin, vortioksetin alternativ;
    - Doza azaltma; «dərman fasiləsi» (drug holiday) (SSGİ-də ehtiyatla);
    - Bupropion adjunkt;
    - Qadınlarda SSGİ induksiyalı disfunksiya üçün sildenafilin əlavə (adjunkt) təyini (rəsmi göstərişdən kənar) — Nurnberg JAMA 2008 RKİ.
3. Psixoterapiya və davranış — orqazm-yönəlmiş terapiya (Heiman & LoPiccolo); KDT, şüurlu fərqindəlik (ing. mindfulness) (Brotto L.A.).
4. Qadınlarda istiqamətli masturbasiya təhsili — istiqamətli masturbasiya (ing. directed masturbation); vibratordan istifadə.
5. Kişilərdə gecikmiş eyakulyasiya — psixoterapiya, masturbasiya nümunəsinin modifikasiyası; FDA tərəfindən təsdiqlənmiş xüsusi farmakoterapiya yoxdur.
6. Hormonal terapiya yalnız təsdiqlənmiş çatışmazlıqda.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Bupropion — SSGİ induksiyalı anorgasmiyada adjunkt və ya keçid.
2. İstiqamətli masturbasiya (ing. directed masturbation) — Heiman və LoPiccolo proqramı; qadınlarda ilkin anorqazmiyada təsirlidir.
3. Mayndfulnes-KDT (şüurlu diqqət-KDT) — Brotto L.A.-nın tədqiqatları; qadın cinsi disfunksiyasında.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Nurnberg H.G. və b. JAMA 2008 — SSGİ induksiyalı cinsi disfunksiyası olan qadınlarda sildenafilin təsiri.
- Brotto L.A.-nın şüurlu diqqət (ing. mindfulness) üzrə tədqiqatları.

9. Proqnoz

Qadınlarda ilkin anorqazmiya üçün istiqamətli masturbasiya 60–90% effektivlik; SSGİ induksiyalı halda dərman strategiyası yaxşılaşma təmin edir.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Qadın penetrasiya ilə orqazma çatmalıdır»

Sübut: əksər qadınlar (təxminən 70%) klitoral stimulyasiyaya ehtiyac duyur; tək penetrasiya ilə orqazm normal variasiyadır, anatomik norma deyil.

Mif 2: «Anorgasmiya qadında „soyuqluq“ əlamətidir»

Sübut: anorgasmiya çox vaxt bilik, texnika, narahatlıq və ya dərmanla bağlıdır; xarakter xüsusiyyəti deyil.

Mif 3: «SSGİ induksiyalı anorqazmiya keçicidir, müalicə tələb etmir»

Sübut: davamlıdır; dərman keçidi və ya adjunkt strategiyalar effektivdir; davam edən əzab-əziyyət klinik mənalı.

Mif 4: «Reseptsiz „orqazm gücləndiriciləri“ effektivdir»

Sübut: sübut zəif; FDA xəbərdarlıqları gizli komponent.

Mif 5: «Vibratör istifadəsi pasiyenti partnyorla orqazmdan məhrum edir»

Sübut: əksinə, ilkin anorqazmiya üzrə təhsildə effektivdir; partnyorla intim əlaqəyə inteqrasiya etmək olar.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. HA02.0 Anorqazmiya. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Nurnberq H.Q. və b. Antidepresanlarla əlaqəli cinsi disfunksiyası olan qadınlarda sildenafil müalicəsi. «JAMA». 2008;300(4):395–404.
4. Brotto L.A. və b. Cinsi funksiya və disfunksiyanın psixoloji və şəxsiyyətlərarası ölçüləri. «Cinsi Tibb Jurnalı» (J Sex Med). 2016;13(4):538–571.
5. Heyman C.R., LoPikkolo C. Orqazmı həyatağı öyrənmək. Prentis Holl; 1988.

XBT-11 **HA20**	**HA20 Ağrılı penetrasiya cinsi pozuntusu (ing. Sexual pain-penetration disorder)** **Sexual pain-penetration disorder**
XBT-10 F52.5	Qeyri-üzvi mənşəli vaginizm
DSM-5-TR F52.6	Genito-pelvik ağrı/penetrasiya pozuntusu

1. Tərif və nozologiya

Ağrılı penetrasiya cinsi pozuntusu (genito-pelvik ağrı/penetrasiya pozuntusu) (XBT-11: HA20; DSM-5-TR: genito-pelvik ağrı/penetrasiya pozuntusu (ing. Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder, F52.6)) — penetrasiya cəhdində: (a) çətinlik, (b) genital və ya pelvik ağrı, (c) ağrı qorxusu, (d) çanaq dibi əzələlərinin gərginliyi. Klassik vaginizm və disparevniya bu vahiddə birləşdirilmişdir.

Müddət ≥ 6 ay; ömür boyu (lifelong) və ya qazanılmış (acquired) formada.

2. Tarixçə

- Sims J.M. (1861) — vaginismus təsviri.
- Masters & Johnson (1970) — çanaq dibi əzələlərinin gərginliyi.
- DSM-5 (2013) — vaginismus və disparevniya birləşdirilərək GPPPD.
- ISSWSH və ACOG göstərişləri.

3. Epidemiologiya

- Qadınlarda yayılma %5–17 təşkil edir. (klinik və qeyri-klinik nümunələrdə).
- Ömür boyu vaginizm — gənc qadınlarda, ilk penetrasiya cəhdində müşahidə olunur.
- Qazanılmış forma — travma, infeksiya, atrofik vaginit, cərrahiyyə sonrası dövrdə.

4. Etiologiya və patogenez

- Bioloji — atrofik vaginit (postmenopozal), vulvodiniya, endometrioz, infeksiya, cərrahi yara.
- Psixoloji — cinsi travma, narahatlıq, qadağalar əsasında qurulmuş tərbiyə, ağrı qorxusu.
- Münasibət və partnyor amilləri.

5. Klinik təzahürlər

- Penetrasiya zamanı çanaq dibinin əzələlərinin refleks gərginliyi.
- Ağrı (yandırıcı, kəsici).
- Penetrasiya qaçınması.
- Hətta ginekoloji müayinə də çətin və ya mümkünsüzdür.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR)

A. Aşağıdakılardan ən azı biri:

- Penetrasiya çətinliyi;
- Penetrasiya cəhdində və ya zamanı vulvovaginal və ya pelvik ağrı;
- Penetrasiya gözləntisi ilə ağrı qorxusu;
- Penetrasiya cəhdində çanaq dibi əzələlərinin gərginliyi.

B. Müddət ≥ 6 ay.

C. Əzab-əziyyət.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ISSWSH və ACOG.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Klinik müsahibə (cinsi tarixçə, ağrı xarakteri, travma).
2. Diqqətli ginekoloji müayinə — ehtiyatla, pasiyent razılığı ilə.
3. Vulvodiniya skrininq (Q-tip test).
4. İnfeksiya, atrofik vaginit, endometrioz istisnası.
5. Çanaq dibi əzələlərinin qiymətləndirilməsi.

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	Fərqləndirici
Vulvodiniya	Lokalizə olunmuş vulva ağrısı, Q-tip testi pozitivdir.
Atrofik vaginit	Postmenopozal, östrogen çatışmazlığı.
Endometrioz	Dərin disparevniya, dismenore.
İnfeksiya (kandida, vaginoz)	Eksudasiya, mikrobioloji təsdiq.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Ginekoloji müayinə.
- Çanaq dibi əzələlərinin qiymətləndirilməsi.
- FSFI; ağrı şkalaları.

8. Müalicə

1. Multidissiplinar yanaşma — çanaq dibinin əzələlərinin fizioterapiyası + KDT + təhsil.
2. Çanaq dibinin əzələlərinin fizioterapiyası — bioloji əks-əlaqə (biofeedback), manual terapiya, dilatator terapiyası (tədrici ölçü artımı).
3. KDT və ekspozisiya (məruz qalma) terapiyası — ağrı qorxusu və qaçınma; ter Kuile M.M. RKİ.
4. Sensate focus və cüt terapiyası.
5. Topikal anestetik (lidokain) — provokasiya olunan vulvodiniyada (Goldstein A.T.).
6. Atrofik vaginitdə lokal östrogen.
7. Botulizm toksini A — refrakter vaginizmdə; sübut bazası artmaqdadır.
8. Antidepresant və ya antikonvulsant (amitriptilin, qabapentin) — neyropatik komponentdə.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Dilatator (genişləndirici) terapiyası — tədrici ölçü artımı; relaksasiya ilə birlikdə.
2. Pelvik Döşəmə Fizioterapiyası — Bioloji əks-əlaqə (biofeedback), manual terapiya.
3. KDT/Ekspozisiya — Ağrı qorxusu və qaçınma.

4. Lokal Östrogen — Atrofik vaginitdə.
5. Botox (off-label) — Refrakter vaginismus; selektiv.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- ter Kuile M.M. və b. KDT vaginismus.
- Goldstein A.T. və b. ISSWSH vulvodyniya konsensus.

9. Proqnoz

Multidissiplinar yanaşma ilə proqnoz əlverişlidir (70–90%).; refrakter halda botox və ya dərinləşdirilmiş psixoloji müdaxilə.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Vaginismus partnyora qarşı emosional rəddir»

Sübut: reflektor əzələ gərginliyi — şüurlu nəzarətdən kənar; ittiham etmək zərərlidir.

Mif 2: «Vaginismus müalicə oluna bilməz»

Sübut: KDT + dilator + fizioterapiya kombinasiyası 70–90% effektivlik; ter Kuile RKİ-ləri.

Mif 3: «Müalicə penetrasiya tezliyini artırmaq üçün edilməlidir»

Sübut: hədəf pasiyentin əziyyətini azaltmaq, ona nəzarət və seçim hissini qaytarmaqdır; performans göstəricisi deyil.

Mif 4: «Lokal anestetik bütün cinsi ağrılarda effektivdir»

Sübut: provokasiya olunan vulvodiniyada təsirlidir; generalizə olunmuş vaginizmdə istifadəsi məhduddur — əsas problem əzələ tensiyasıdır.

Mif 5: «Penetrasiya cəhdini „məcburi məşq“ etmək kömək edir»

Sübut: tələsik, ağrılı təkrarlama qaçınmanı və qorxunu artırır; tədrici, nəzarətli ekspozisiya effektivdir.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. HA20 Genital-çanaq ağrısı/penetrasiya pozuntusu. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.

3. Ter Küyle M.M. və b. Ömür boyu vajinizmi olan qadınlarda terapevt dəstəyi ilə ekspozisiya: randomizə edilmiş klinik sınaq (RCT). «Məsləhət və Klinik Psixologiya Jurnalı» (J Consult Clin Psychol). 2013;81(6):1127–1136.
4. Qoldsteyn A.T. və b. Vulvodiniya: qiymətləndirmə və müalicə. «Cinsi Tibb Jurnalı» (J Sex Med). 2016;13(4):572–590.
5. Bergeron S. və b. Qadın və kişilərdə genital ağrı: bu, cinsi həyatınızdan daha çox ağrıda bilər. «Cinsi Tibb İcmalı» (Sex Med Rev). 2020.

XBT-11 **HA40**	**HA40 CİNSİ DİSFUNKSİYALARDA VƏ CİNSİ AĞRI POZUNTULARINDA ETİOLOJİ MÜLAHİZƏLƏR** **Aetiological considerations in sexual dysfunctions and sexual pain disorders**
XBT-10 F52.8	Üzvi pozuntu və ya xəstəliklə əlaqədar olmayan digər cinsi disfunksiya
DSM-5-TR —	—

1. Tərif və nozologiya

Digər cinsi disfunksiyalar (XBT-11: HA40) — başqa fiziki xəstəlik, dərman, maddə və ya psixi pozuntu kontekstində meydana çıxan cinsi disfunksiyalar (istək, həyəcan, orqazm, ağrı sahələrini əhatə edə bilər). Spesifik HA00–HA20 kateqoriyalarına uyğunlaşmayan və ya birlikdə olan hallar.

Alt-tiplər (XBT-11): tibbi vəziyyət, zədə və ya cərrahiyyə/şüa müalicəsinin təsirləri (HA40.0); psixoloji və ya davranış amilləri, psixi pozuntular da daxil olmaqla (HA40.1); psixoaktiv maddə və ya dərman istifadəsi (HA40.2); bilik və ya təcrübə çatışmazlığı (HA40.3); münasibət amilləri (HA40.4); mədəni amillər (HA40.5); digər dəqiqləşdirilmiş (HA40.Y); dəqiqləşdirilməmiş (HA40.Z).

2. Tarixçə

- DSM-5 (2013) — «Maddə/dərman induksiyalı cinsi disfunksiya» anlayışının rəsmiləşdirilməsi.
- 2000-ci illər — SSGİ induksiyalı cinsi disfunksiya geniş təsvir edilmişdir (Montejo A.L.-nın tədqiqatları) (Montejo A.L. araşdırmaları).
- Post-SSGİ cinsi disfunksiyası (PSSD) — Bahrick A. (2008); Avropa Dərman Agentliyi (EMA) tərəfindən 2019-cu ildə təsdiqlənmişdir.

3. Epidemiologiya

- SSGİ istifadəsində cinsi disfunksiya %30–70 tezliklə müşahidə olunur.
- Diabetik kişilərdə erektil disfunksiya %35–75 təşkil edir.
- Kardiovaskulyar xəstəliklərdə yayılma yüksəkdir.
- Antipsixotiklər (xüsusilə risperidon, paliperidon) hiperprolaktinemiya nəticəsində cinsi disfunksiya yaradır.

4. Etiologiya və patogenez

- Dərmanlar: SSGİ, SNGİ, antipsixotik (D2 blokadası, hiperprolaktinemiya), antihipertenziv (β-blokator, tiazid), opioid, 5α-reduktaza inhibitorlar (finasterid — postfinasterid sindromu şübhəsi), antikonvulsant.
- Maddələr: alkohol, opioid, xroniki kannabis istifadəsi, stimulyantlar.
- Tibbi xəstəliklər: diabet, kardiovaskulyar, neyroloji (MS, Parkinson, onurğa travması), endokrin (hipoqonadizm, hiperprolaktinemiya, tiroid), pelvik cərrahiyyə və radioterapiya, xroniki böyrək çatışmazlığı.
- Psixi pozuntular: depressiya, narahatlıq, PTSP, şizofreniya.

5. Klinik təzahürlər

- İstək azalması, həyəcan/ereksiya pozuntusu, anorgasmiya, ağrı — etiologiyaya görə.
- Zaman əlaqəsi — dərmanın/maddənin başlanğıcı ilə.
- PSSD — SSGİ dayandırılmasından sonra davam edən cinsi disfunksiya, genital uyuşma.

6. Diaqnoz

6.1 Vahid diaqnostik meyarlar (DSM-5-TR)

A. Klinik mənalı cinsi disfunksiya simptomatikası.

B. tarixçə, fiziki müayinə və ya laboratoriya nəticələrindən sübut: simptomlar dərman, maddə və ya tibbi xəstəliyin birbaşa nəticəsidir.

C. Əzab-əziyyət.

6.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Montejo A.L. və b. — SSGİ induksiyalı disfunksiya.
- EMA (2019) — PSSD-ni SSGİ dərman təlimatına daxil etmişdir.

6.3 Diaqnostika alqoritmi

1. Tam dərman və maddə tarixçəsi.
2. Tibbi və endokrin qiymətləndirmə (testosteron, prolaktin, qlükoza, HbA1c, lipid, tiroid).
3. Cinsi funksiya şkalaları (FSFI, IIEF, ASEX).
4. Psixi komorbidlik skrininq.
5. Pelvik müayinə (qadınlarda).

6.4 Differensial diaqnostika

Vəziyyət	**Fərqləndirici**
Primary HSDD/ED/Anorgasmiya	Tibbi və dərman sübutu yoxdur.
Depressiv pozuntu	Anhedoniya, əhval pozuntusu simptomları üstünlük təşkil edir.
PSSD	SSGİ kəsildikdən sonra davam edən cinsi disfunksiya.

7. Müayinə və qiymətləndirmə

- Hormonal panel, qlükoza, lipid.
- Qadın cinsi funksiya indeksi (FSFI), beynəlxalq erektil funksiya indeksi (IIEF), Arizona cinsi təcrübə şkalası (ASEX).
- Çanaq və ya uroloji müayinə göstəriş olduqda.

8. Müalicə

1. Etioloji yanaşma — birinci sıra:
    - Dərmana bağlı — doza azaltma, dərman keçidi (bupropion, mirtazapin, vortioksetin, aripiprazol — antidepresant və ya antipsixotik strategiyalarda);

- Tibbi vəziyyət idarəsi (diabet, hipertenziya, hipoqonadizm).

2. Adjunkt farmakoterapi — sildenafil (PDE5) ED-də və SSGİ induksiyalı qadın disfunksiyasında (Nurnberg JAMA 2008); bupropion adjunkt.
3. Hiperprolaktinemiyada — antipsixotik keçid (aripiprazol, kvetiapin) və ya doza modifikasiyası; dopamin agonisti yalnız endokrin köməyi ilə.
4. Psixoterapiya və cüt terapiyası — psixogen komponentdə.
5. Pasiyent təhsili və məlumatlı razılıq (informed consent) — antidepressant və antipsixotik başlamadan əvvəl cinsi yan təsirlər haqqında məlumat vacibdir.
6. PSSD — spesifik təsdiqlənmiş müalicə yoxdur; klinik dəstək və izləmə; tədqiqatlar davam edir.

8.1 Müalicə metodikaları

1. Dərman Keçidi (ing. Medication Switch) — SSGİ → bupropion/mirtazapin/vortioksetin; risperidon → aripiprazol.
2. Sildenafil Adjunkt — SSGİ induksiyalı disfunksiya (kişi və qadın); Nurnberg JAMA RKİ.
3. Bupropion Adjunkt — İstək və orqazm pozuntularında.
4. Antipsixotik Keçidi (aripiprazol) — Hiperprolaktinemiya olduqda.
5. Pasiyent Təhsili (ing. Patient Education) — Məlumatlı razılıq (informed consent); uzunmüddətli riskin müzakirəsi.

8.2 Mənbələr arasında fərqlər

- Montejo A.L. və b. — antidepressant cinsi yan təsir alqoritmləri.
- Avropa Dərman Agentliyi (EMA), 2019 — PSSD riski barədə məlumat.
- NICE və APA göstərişləri — antidepressant cinsi yan təsirlərin idarəsi.

9. Proqnoz

Etioloji amillərin idarə olunması və dərman keçidi ilə əksər hallar yaxşılaşır; PSSD nadir hallarda davamlı qala bilər.

10. Mif və yanlış inanclar

Mif 1: «Antidepresanların cinsi yan təsirləri „müvəqqəti“dir və müdaxilə tələb etmir»

Sübut: Montejo tədqiqatları — yan təsirlər davamlıdır (30–70%); aktiv idarəetmə tələb edir.

Mif 2: «Post-SSGİ cinsi disfunksiyası (PSSD) ayrı klinik vahid deyil»

Sübut: EMA 2019 — PSSD riski SSGİ etiketinə daxil edildi; klinik cəhətdən tanınmış vahiddir.

Mif 3: «Antipsixotiklərlə əlaqəli cinsi disfunksiya hamı üçün eynidir»

Sübut: risperidon və paliperidon yüksək hiperprolaktinemiya riski daşıyır; aripiprazol və kvetiapin daha az; dərman dəyişdirilməsi effektivdir.

Mif 4: «Tibbi xəstəliyə bağlı cinsi disfunksiya yalnız xəstəliyin nəticəsidir, müdaxilə yoxdur»

Sübut: diabetik ED-də PDE5 effektivdir; kardiovaskulyar reabilitasiyada cinsi funksiya yaxşılaşır; aktiv müdaxilə vacibdir.

Mif 5: «Antidepresan qəbuluna başlamadan əvvəl cinsi yan təsirləri müzakirə etmək lazım deyil»

Sübut: məlumatlı razılıq (informed consent) etik və klinik tələbdir; sonradan yaranan yan təsirlər pasiyentin inamsızlığına və müalicə uyğunluğunun azalmasına səbəb olur.

11. Mənbələr

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11. HA40 Cinsi disfunksiyalar və cinsi ağrı pozuntularında etioloji mülahizələr. 2024.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). DSM-5-TR. 2022.
3. Monteco A.L., Lorka Q., İskyerdo C.A., Riko-Vilyademoros F. Antidepresan vasitələrlə əlaqəli cinsi disfunksiyanın tezliyi: 1022 ambulator pasiyentin prospektiv çoxmərkəzli tədqiqi. «Klinik Psixiatriya Jurnalı» (J Clin Psychiatry). 2001;62(Əlavə 3):10–21.
4. Avropa Dərman Agentliyi (EMA). Dərmanların Risk Qiymətləndirilməsi üzrə Farmakoqovigilyans Komitəsi (PRAC) SSGİ/SNGİ müalicəsindən sonra cinsi disfunksiya ilə bağlı məhsul məlumatına yeni xəbərdarlıqların əlavə edilməsini tövsiyə edir. 2019.
5. Nurnberq H.Q. və b. Antidepresanlarla əlaqəli cinsi disfunksiyası olan qadınlarda sildenafil müalicəsi. «JAMA». 2008;300(4):395–404.
6. Bahrik A.S. Antidepresan dərmanların dayandırılmasından sonra cinsi disfunksiya yan təsirlərinin davam etməsi. «Açıq Psixologiya Jurnalı» (Open Psychol J). 2008;1:42–50.

ƏLAVƏLƏR

ƏLAVƏ A

MONİTORİNQ VƏ MÜAYİNƏ STANDARTLARI

Bu əlavə psixotrop dərmanların istifadəsində təhlükəsizlik monitorinqi və psixiatrik xəstələrin tibbi vəziyyətinin izlənməsi üçün standart protokolları təqdim edir.

A.1. Antipsikotik terapiyada metabolik monitorinq

Atipik antipsixotiklər – xüsusilə olanzapin, kvetiapin, klozapin – metabolik sindrom riskini artırır (çəki artımı, dislipidemiya, insulinə müqavimət, diabet).

Monitorinq cədvəli (APA/ADA 2004, ADA/APA/AACE/NAASO konsensusu):

Parametr	Başlanğıc	4 həftə	8 həftə	12 həftə	Rüblük	İllik
Şəxsi/ailə tarixçəsi	✓	—	—	—	—	✓
Çəki, bel çevrəsi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arterial təzyiq	✓	—	—	✓	—	✓
Acqarına qlükoza (mmol/L)	✓	—	—	✓	—	✓
Acqarına lipid profili	✓	—	—	✓	—	✓ (2 ildə bir)

Anomaliya aşkar edilərsə:

- Çəki artımı ≥7%: dərmanın dəyişdirilməsi nəzərdən keçirilməlidir (aripiprazol, ziprasidon – metabolik neytral);
- HbA1c ≥6,5% və ya acqarına qlükoza ≥7,0 mmol/L: diabet konsultasiyası;
- LDL ≥3,4 mmol/L: pəhriz, statin.

Klozapinlə əlaqəli monitorinq (aqranulositoz riskinə görə):

Müddət	**Tezlik**
İlk 6 ay	Həftəlik leykosit sayı (WBC) və mütləq neytrofil sayı (ANC)
7–12 ay	2 həftədə bir
12+ ay	Aylıq

ANC göstəriciləri:

- ≥2,0 × 10^9/L: normal — müalicə davam etdirilir;
- 1,5–2,0 × 10^9/L: həftəlik izləmə;
- 1,0–1,5: 2 gündə bir izləmə, hematoloq konsultasiyası;
- <1,0: dərman dayandırılır, hematoloq müdaxiləsi.

Antipsikotiklərdə EKG monitorinqi:

- QTc uzanması riski: xüsusilə ziprasidon, venadaxili haloperidol və ondansetron birlikdə;
- Risk faktorları olan pasiyentlərdə (ürək xəstəliyi, elektrolit pozuntusu, 65 yaşdan yuxarı) başlanğıc EKQ çəkilməlidir;
- QTc >500 msn və ya bazadan >60 msn artım — dərmanın dəyişdirilməsi;
- Risk artıran dərmanlar: klorpromazin, haloperidol (yüksək), tioridazin.

Hiperprolaktinemiya:

- Risperidon, amisulprid, paliperidon — yüksək risk;
- Simptomlar: amenore, galaktoreya, cinsi disfunksiya, osteoporoz;
- Başlanğıcda bazal prolaktin; simptom yarandıqda təkrar.

A.2. Litium monitorinqi

Dar terapevtik pəncərə — səviyyə 0,6–1,2 mEq/L, >1,5 mEq/L toksikdir.

Parametr	**Başlanğıc**	**Hər 6 ay**	**İllik**
Litium səviyyəsi	Həftəlik 1-ci ay, sonra hər 6 ay	✓	—
Kreatinin, eGFR	✓	✓	—

Parametr	Başlanğıc	Hər 6 ay	İllik
TSH	✓	✓	—
Elektrolitlər	✓	✓	—
Kalsium	✓	—	✓
EKG	✓ (50+ yaş)	—	—
Hamiləlik testi	Doğuş yaşlı qadınlarda	—	—

Litium intoksikasiyası əlamətləri:

- Tremor (daha güclü);
- Taxikardiya;
- Diareya, qusma;
- Yavaş, dolaşıq nitq;
- Ataksiya;
- Qıcolma — ağır hallarda.

Vəziyyət dəyişikliyində səviyyə yoxla: dehidratasiya, NSAİD əlavəsi, ACE inhibitor əlavəsi, böyrək funksiyasında dəyişiklik.

A.3. Antiepileptiklər (valproat, karbamazepin, lamotrigin)

Valproat:

Parametr	Başlanğıc	Hər 6 ay
Ümumi qan analizi (CBC) — trombositopeniya	✓	✓
Qaraciyər funksiyası (AST, ALT)	✓	✓
Valproat səviyyəsi	—	Simptom və ya şübhə ilə
Pankreatit əlamətlərinin izlənməsi	—	Hər ziyarət
Hamiləlik testi	**Doğuş yaşlı qadınlarda mütləqdir**	**Hər rüb**

Kritik: valproat doğuş yaşlı qadınlarda neyral boru defekti və koqnitiv zərər riskinə görə yalnız effektiv kontrasepsiya ilə, digər seçimlər əvvəlcə qiymətləndirildikdən sonra təyin edilməlidir.

Karbamazepin:

- Ümumi qan analizi (CBC) və qaraciyər funksiyası — başlanğıcda, 1-ci ayda, sonra rüblük;
- HLA-B*1502 testi Asiya mənşəli pasiyentlərdə (Stevens-Johnson riski);
- Autoinduksiya səbəbindən səviyyə ilk 4 həftədə azalır — nəzarət tələb olunur.

Lamotrigin:

- Yavaş titrasiya — Stevens-Johnson sindromu riski;
- Başlanğıc 25 mq həftədə, 4–8 həftə ərzində hədəf dozaya;
- Valproat ilə birlikdə: başlanğıc 12,5 mq — valproat lamotrigin metabolizmini yavaşlatır;
- Dəri reaksiyası olsa – dərhal dayandır.

A.4. SSGİ və SNGİ monitorinqi

- Hiponatremiya riski — xüsusilə yaşlılarda, diuretik istifadə edənlərdə;
- Bazal Na, 1 ay sonra simptom ilə;
- İntihar (suisid) riskinin artması xüsusilə 25 yaşdan aşağı başlanğıcda — ilk 1 –2 ay yaxın monitorinq;
- QTc uzanma — esitalopram, sitalopram (yüksək dozalarda);
- Serotonin sindromu (MAOİ və ya triptan və s. kombinasiyada) – simptomlar barədə məlumatlandırma.

A.5. Benzodiazepin istifadəsi

- Maksimum müddət — 2–4 həftə;
- Uzunmüddətli istifadədə asılılıq riski yüksəkdir;
- Azaltma sxemi (tapering): 25% hər 2 həftə, bəzən daha yavaş;
- Geri qayıtma (rebound) simptomları (narahatlıq, yuxusuzluq, tremor) gözləniləndir və müvəqqətidir.

A.6. Psixoterapiya monitorinqi

Keyfiyyət göstəriciləri:

- Seansın müddəti və tezliyi;
- Pasiyentin simptom şkalaları (PHQ-9, ÜTP-7 və s.) hər 4–6 həftə;
- Funksional göstəricilər;
- Terapevtik əlaqə qiymətləndirilməsi (ing. Working Alliance Inventory);
- Qoyulmuş məqsədlərə çatma;
- Residiv əlamətləri.

Superviziya və həmkarla məsləhətləşmə — mürəkkəb hallarda, həmçinin həkimin öz istəyi ilə.

ƏLAVƏ B

NEYROİNKİŞAF POZUNTULARININ SKRİNİNQ ŞKALALARI

İstifadə qaydaları: Bu şkalalar diaqnostik deyil, skrininq alətlərdir. Müsbət nəticə — ixtisaslaşmış klinik qiymətləndirmə üçün göstərişdir, diaqnoz deyil. Qəti diaqnoz klinik müsahibə, ətraflı qiymətləndirmə və (lazım olduqda) standartlaşdırılmış diaqnostik alətlər (ADOS-2, ADI-R, WISC-V və s.) vasitəsilə qoyulur.

Lisenziya statusu (Məsuliyyətdən azadolma qeydi): Bu əlavədə tam mətnlə təqdim edilən şkalalar (M-CHAT-R, AQ-10, ASRS v1.1, SNAP-IV) elmi tədqiqat və klinik istifadə üçün tərtibatçılar tərəfindən açıq şəkildə təqdim edilmiş alətlərdir. Bu kitab diaqnostik testlərin toplusu deyil, klinik təlimatdır: lisenziyalı alətlər (WISC-V, ADOS-2, Vineland-3 və s. bax B.5) mətndə əks olunmur, onların əldə edilməsi və istifadəsi hüquq sahiblərindən (Pearson, WPS, MHS və s.) rəsmi lisenziya alınmasını və ixtisaslı mütəxəssis tələb edir.

B.1. M-CHAT-R: Autizm spektri üzrə dəyişdirilmiş yoxlama siyahısı, yenidən işlənmiş (ing. Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) – 16–30 aylıq uşaqlar üçün

Orijinal müəlliflər: Dayana L. Robins, Debora Feyn, Marianna Barton, 2009.

Orijinal istinad: Robins D.L., Feyn D., Barton M. M-CHAT-R/F — uşaqlarda autizmin erkən aşkarlanması üçün dəyişdirilmiş yoxlama siyahısı [M-CHAT-R/F]. Müəllif nəşri, 2009; «Pediatriya» (Pediatrics), 2014; 133: 37–45.

Təlimat

Bu sorğu vərəqi uşağınızın gündəlik davranışı ilə bağlı 20 sualdan ibarətdir. Valideyn və ya ilkin qayğı göstərən şəxs tərəfindən doldurulur. Hər suala BƏLİ və ya XEYR kimi cavab verin — uşağınızın adətən necə davrandığı əsasında. Əgər davranışı bir-iki dəfə görmüsünüzsə, amma ümumiyyətlə uşaq belə etmirsə, XEYR cavab verin.

Suallar

№	Sual	Bəli	Xeyr
1	Əgər siz otağın o tərəfindəki bir şeyə baxsanız, uşağınız da ora baxırmı? (Məsələn, uçan təyyarəyə, böyük heyvana və ya oyuncağa)	—	—
2	Heç uşağınızın kar olduğunu düşünmüsünüzmü?	—	—
3	Uşağınız xəyali (simvolik) oyunlar oynayırmı? (Məsələn, boş fincandan içmək kimi, telefonla danışmaq kimi, kuklaya yemək vermək kimi)	—	—
4	Uşağınız əşyalara dırmanmağı sevirmi? (mebel, pilləkən, ağac)	—	—
5	Uşağınız ovuclarını, barmaqlarını və ya bədəninin digər hissələrini gözünün qarşısında qeyri-adi hərəkətlər edirmi?	—	—

№	Sual	Bəli	Xeyr
6	Uşağınız istədiyi bir şeyə işarə edirmi? (Məsələn, əlçatmaz yerdə olan oyuncağı göstərmək üçün)	—	—
7	Uşağınız maraqlı bir şeyə diqqətinizi cəlb etmək üçün işarə edirmi? (Məsələn, göydəki təyyarə və ya böyük maşın)	—	—
8	Uşağınız başqa uşaqlara maraq göstərirmi? (Məsələn, oyun parkında uşaqlara baxır, onlara qoşulmağa çalışır)	—	—
9	Uşağınız sizə bir şey göstərməklə və ya önünüzə qoymaqla sizinlə paylaşırmı (bunu kömək üçün deyil, paylaşmaq üçün)?	—	—
10	Uşağınız adı çağırıldıqda cavab verirmi?	—	—
11	Uşağınıza gülümsədiyinizdə, o da sizə gülümsəyirmi?	—	—

№	Sual	Bəli	Xeyr
12	Uşağınız gündəlik səslərdən narahat olurmu? (Məsələn, tozsoran, yüksək musiqi)	—	—
13	Uşağınız yeriyirmi?	—	—
14	Uşağınız siz onunla oynayarkən və ya paltarını geyindirərkən gözlərinizə baxırmı?	—	—
15	Uşağınız sizin etdiklərinizi təqlid edirmi? (Məsələn, siz üz-gözünüzü oynatdıqda, o da eyni şeyi edir)	—	—
16	Uşağınız bir şey eşitdikdə nə baş verdiyini görmək üçün sizə baxırmı?	—	—
17	Uşağınız diqqətinizi cəlb etməyə çalışırmı? (Məsələn, sizə baxmaq, tərif almaq üçün, «bax!» demək)	—	—
18	Uşağınız anladığı sözlərə cavab verirmi? (Məsələn, «topu mənə ver» və ya «kitabı götür» deyildikdə)	—	—

№	Sual	Bəli	Xeyr
19	Əgər bir şey yeni və ya qəribə baş verərsə, uşağınız sizin reaksiyanızı görmək üçün üzünüzə baxırmı?	—	—
20	Uşağınız hərəkətli oyunları sevirmi? (Məsələn, havada yellənmək, dizinizin üstündə tullandırılmaq)	—	—

Hesablama

Risk xalı = XEYR cavablarının sayı, istisna olmaqla, 2, 5 və 12-ci suallarda BƏLİ cavabı risk əlaməti hesab edilir.

Yəni:

- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ci suallarda XEYR cavabı risk əlaməti hesab edilir.
- 2, 5, 12-ci suallarda BƏLİ cavabı risk əlaməti hesab edilir.

Nəticələrin şərhi

Xal	Risk səviyyəsi	Tövsiyə
0–2	Aşağı risk	Əlavə qiymətləndirmə tələb olunmur (digər risk amilləri yoxdursa); 24 aya qədər yenidən skrininq tövsiyə olunur
3–7	Orta risk	**M-CHAT-R/F (Follow-up) tələb olunur** — strukturlaşdırılmış izləmə müsahibəsi; tibb işçisi tərəfindən aparılır

Xal	Risk səviyyəsi	Tövsiyə
8–20	Yüksək risk	**Təcili ASP (autizm spektri pozuntusu) diaqnostik qiymətləndirməsi və erkən müdaxilə proqramına göndərmə tələb olunur**

Qeyd: M-CHAT-R – Azərbaycan dilində müxtəlif klinikalarda istifadə olunur, lakin rəsmi etibarlılıq yoxlanışı (validasiya) Azərbaycan əhalisində məhduddur. Yuxarıdakı tərcümə klinik praktika üçün nəzərdə tutulub; elmi tədqiqatlarda rəsmi təsdiqlənmiş tərcümə istifadə olunmalıdır (rəsmi tərcümələr üçün: https://mchatscreen.com).

B.2. AQ-10 (Autizm Spektri Kvotienti-10): qısa autizm spektri qiymətləndirməsi (16 yaş və yuxarı)

Orijinal müəlliflər: Kerri Allison, Boni Auyeung, Saymon Baron-Koen, 2012.

Orijinal istinad: Allison C., Auyeung B., Baron-Koen S. Autizm skrininqi üçün qısa «qırmızı bayraqlar»: qısa Autizm Spektri Kvotienti (AQ-10) [Toward brief «red flags» for autism screening: the short Autism Spectrum Quotient (AQ-10)]. «Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyasının Jurnalı» (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry), 2012; 51: 202–212.

Təlimat

Aşağıdakı 10 ifadə haqqında nə düşünürsünüz? Hər ifadə üçün Mütləq razıyam, Qismən razıyam, Qismən razı deyiləm, Mütləq razı deyiləm variantlarından birini seçin.

Suallar

№	İfadə
1	Mən tez-tez kiçik səslərə diqqət yetirirəm — başqaları bunları eşitmədikdə

№	İfadə
2	Mən adətən kiçik detallara deyil, ümumi şəklə daha çox diqqət edirəm
3	Mən eyni vaxtda birdən çox işi asanlıqla yerinə yetirə bilirəm
4	Əgər məni kimsə yayındırarsa, əvvəlki işimə tez qayıda bilirəm
5	Başqası mənimlə danışarkən onun nə demək istədiyini asanlıqla anlayıram
6	Məni dinləyən şəxsin darıxdığını asanlıqla müəyyən edirəm
7	Hekayə oxuyarkən personajların nə düşündüyünü başa düşməkdə çətinlik çəkirəm
8	Mən müəyyən kateqoriyalar üzrə məlumat toplamağı xoşlayıram (məsələn, avtomobil növləri, quşlar, qatarlar)
9	Mən bir insanın üzünə baxaraq onun nə düşündüyünü və ya nə hiss etdiyini asanlıqla müəyyən edirəm
10	Mən insanların niyyətlərini anlamaqda çətinlik çəkirəm

Hesablama

Sual	«Mütləq razıyam / Qismən razıyam» – 1 bal	«Mütləq razı deyiləm / Qismən razı deyiləm» – 1 bal
1	✓	—
2	—	✓
3	✓	—
4	✓	—

Sual	«Mütləq razıyam / Qismən razıyam» – 1 bal	«Mütləq razı deyiləm / Qismən razı deyiləm» – 1 bal
5	—	✓
6	—	✓
7	✓	—
8	✓	—
9	✓	—
10	✓	—

Cəmi xal 10 baldan hesablanır

Nəticələrin şərhi

Xal	Tövsiyə
0–5	ASP (autizm spektri pozuntusu) diaqnostik qiymətləndirməsinə ehtiyac azdır
≥6	**Ətraflı ASP klinik qiymətləndirməsi tövsiyə olunur**

Qeyd: AQ-10 klassik AQ-50-nin qısa versiyasıdır. NICE CG142 (Böyük Britaniya) tərəfindən ilkin səhiyyədə yetkinlərdə ASP skrininqi üçün rəsmi tövsiyə edilir. Həssaslıq təxminən 77%, spesifiklik 36–41%. AQ-10 xüsusilə «öz-özünün skrinigi»ndə etibarlıdır və klinikçinin ilkin müsahibəsi ilə birlikdə istifadə olunmalıdır.

B.3. ASRS v1.1: Yetkin DDHP üzrə Özünü Bildirmə Şkalası

Orijinal müəlliflər: ÜST, Ronald C. Kesler və əməkdaşları, Harvard Tibb Məktəbi, 2005.

Orijinal istinad: Kesler R.C., Adler L., Eyms M. və b. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yetkinlərdə DDHP üzrə özünüqiymətləndirmə şkalası (ASRS) [The

World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)]. «Psixoloji Tibb» (Psychological Medicine), 2005; 35: 245–256.

Təlimat

Bu şkala yetkinlərdə DDHP simptomlarının skrininqi üçündür. Aşağıdakı 6 suala — son 6 ay ərzində özünüzü necə hiss etdiyinizə — əsaslanaraq cavab verin. Hər sual üçün Heç vaxt, Nadirən, Bəzən, Tez-tez, Çox tez-tez variantlarından birini seçin.

Hissə A – Birincili skrininq (6 sual)

№	**Sual**	**Heç vaxt**	**Nadirən**	**Bəzən**	**Tez-tez**	**Çox tez-tez**
1	Bir layihənin çətin hissəsi başa çatdıqdan sonra son xırdalıqları bitirməkdə nə qədər tez-tez çətinlik çəkirsiniz?	—	—	—	—	—
2	Təşkilat tələb edən bir iş görərkən işləri sıraya qoymaqda nə qədər tez-tez çətinlik çəkirsiniz?	—	—	—	—	—

№	Sual	Heç vaxt	Nadirən	Bəzən	Tez-tez	Çox tez-tez
3	Görüş və ya öhdəlikləri xatırlamaqda nə qədər tez-tez problem yaşayırsınız?	—	—	—	—	—
4	Çox düşüncə tələb edən bir tapşırığınız olduqda, nə qədər tez-tez başlamaqdan çəkinirsiniz və ya onu təxirə salırsınız?	—	—	—	—	—

№	Sual	Heç vaxt	Nadirən	Bəzən	Tez-tez	Çox tez-tez
5	Uzun müddət oturmaq məcburiyyətində olduğunuz zaman nə qədər tez-tez əl və ayaqlarınızı qımıldadırsınız və ya dartırsınız?	—	—	—	—	—
6	Nə qədər tez-tez «motorla işləyən» kimi həddindən artıq fəal və ya özünüzü bir şey etmək məcburiyyətində hiss edirsiniz?	—	—	—	—	—

Hesablama (Hissə A üçün)

Cədvəldə qalın şriftlə verilmiş cavablar – müsbət əlamətdir.

Sual	Müsbət əlamət sayılan cavablar
1	**Bəzən, Tez-tez, Çox tez-tez**
2	**Bəzən, Tez-tez, Çox tez-tez**
3	**Bəzən, Tez-tez, Çox tez-tez**
4	**Tez-tez, Çox tez-tez**
5	**Tez-tez, Çox tez-tez**
6	**Tez-tez, Çox tez-tez**

Cəmi müsbət əlamət sayı: ____ / 6

Nəticələrin şərhi

Müsbət əlamət sayı	Şərh
0–3	Simptomlar yetkin DDHP üçün tipik deyil
≥4	**Simptomlar yetkin DDHP üçün yüksək dərəcədə uyğundur. Tibbi qiymətləndirmə tövsiyə olunur.**

Hissə B – Genişləndirilmiş sorğu (12 əlavə sual)

Hissə A müsbət olduqda Hissə B sualları (12 əlavə sual) klinik qiymətləndirmə ilə birlikdə tətbiq edilir. Hissə B tam versiyası tərtibatçıların rəsmi saytından əldə edilə bilər: https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php

Qeyd: ASRS v1.1 – ÜST tərəfindən hazırlanmış, dünyada ən çox istifadə olunan yetkin DDHP skrininq şkalasıdır. Sonralar dünyaca tanınmış Kessler tərəfindən ASRS-5 işlənib hazırlanmışdır – daha qısa 5 suallı versiya. Hər iki versiya skrininq üçün uyğundur, ASRS v1.1 hələ də geniş istifadədədir.

B.4. SNAP-IV: Swanson, Nolan və Pelham Qiymətləndirmə Şkalası (uşaqlarda DDHP)

Orijinal müəlliflər: Ceyms M. Swanson, Meri Nolan, Uilyam Pelham, 1983.

Orijinal istinad: Swanson J.M. Məktəb əsaslı qiymətləndirmə və müdaxilələr: ADD olan şagirdlər üçün [School-based assessments and interventions for ADD students]. İrvayn, Kaliforniya: KC Publishing, 1992.

Təlimat

SNAP-IV – uşaqlarda DDHP simptomlarının DSM-5-TR (Psixi pozuntuların diaqnostik və statistik təlimatı, 5-ci nəşr, yenidən işlənmiş) meyarlarına əsaslanan qiymətləndirmədir. Valideyn və ya müəllim tərəfindən doldurulur. Hər simptomun son 1 ay ərzində uşağınızda nə dərəcədə müşahidə olunduğunu qeyd edin: Heç (0), Bir az (1), Kifayət qədər (2), Çox (3).

Suallar (SNAP-IV qısa versiya — 26 sual)

Diqqətsizlik subskalası (1–9-cu maddələr):

№	İfadə	0	1	2	3
1	Tez-tez məktəb işində və ya digər fəaliyyətlərdə diqqətsiz səhvlərə yol verir	—	—	—	—
2	Tez-tez diqqətini tapşırıqlarda və ya oyunlarda saxlamaqda çətinlik çəkir	—	—	—	—
3	Tez-tez birbaşa danışıldıqda dinləmir kimi görünür	—	—	—	—

№	İfadə	0	1	2	3
4	Tez-tez təlimatlara əməl etmir və məktəb işini, gündəlik tapşırıqları bitirmir	—	—	—	—
5	Tez-tez tapşırıqları və fəaliyyətləri təşkil etməkdə çətinlik çəkir	—	—	—	—
6	Tez-tez davamlı zehni səy tələb edən tapşırıqlardan qaçır, xoşlamır və ya könülsüzlüklə yerinə yetirir	—	—	—	—
7	Tez-tez tapşırıqlar və ya fəaliyyətlər üçün lazımi əşyaları itirir (məktəb materialları, karandaş, kitab)	—	—	—	—

№	İfadə	0	1	2	3
8	Tez-tez xarici stimullarla asanlıqla dağılır	—	—	—	—
9	Tez-tez gündəlik fəaliyyətləri yaddan çıxarır	—	—	—	—

Hiperaktivlik-impulsivlik subskalası (10–18-ci maddələr):

№	İfadə	0	1	2	3
10	Tez-tez əl və ayaqlarını qımıldadır və ya oturduğu yerdə dartır	—	—	—	—
11	Tez-tez oturması gözlənilən yerlərdə (məsələn, sinifdə) yerindən qalxır	—	—	—	—
12	Tez-tez uyğun olmayan vəziyyətlərdə həddindən artıq qaçır və ya dırmaşır	—	—	—	—

№	İfadə	0	1	2	3
13	Tez-tez sakit oynamaqda çətinlik çəkir	—	—	—	—
14	Tez-tez «hərəkətli» və ya «motorla işləyən» kimi davranır	—	—	—	—
15	Tez-tez həddindən artıq danışır	—	—	—	—
16	Tez-tez sual bitməmiş cavab verir	—	—	—	—
17	Tez-tez öz növbəsini gözləyə bilmir	—	—	—	—
18	Tez-tez başqalarının söhbətini və ya oyununu kəsir	—	—	—	—

Müxalifət-etiraz davranışı subskalası (19–26-cı maddələr):

№	İfadə	0	1	2	3
19	Tez-tez özünü itirir	—	—	—	—
20	Tez-tez yetkinlərlə mübahisə edir	—	—	—	—

№	İfadə	0	1	2	3
21	Tez-tez yetkinlərin tələblərinə və ya qaydalara qarşı çıxır	—	—	—	—
22	Tez-tez qəsdən başqalarını qıcıqlandırır	—	—	—	—
23	Tez-tez öz səhvləri və ya pis davranışı üçün başqalarını günahlandırır	—	—	—	—
24	Tez-tez başqaları tərəfindən asanlıqla qıcıqlandırılır	—	—	—	—
25	Tez-tez əsəbi və kinlidir	—	—	—	—
26	Tez-tez qisasçı və ya kinli davranır	—	—	—	—

Hesablama

Hər subskala üzrə orta bal:

- Diqqətsizlik subskalası (1–9): cəm ÷ 9 = ____

- Hiperaktivlik-impulsivlik subskalası (10–18): cəm ÷ 9 = _____
- Müxalifət-etiraz subskalası (19–26): cəm ÷ 8 = ____

Nəticələrin şərhi (orta səviyyələr)

Subskala	Valideyn: müsbət sərhəd	Müəllim: müsbət sərhəd
Diqqətsizlik	≥1,78	≥2,56
Hiperaktivlik-impulsivlik	≥1,44	≥1,78
Opozisiyon-etiraz	≥1,88	≥2,00

Bu sərhədlər Bussing və b., 2008 məlumatlarına əsaslanır və ABŞ əhalisi üçündür. Azərbaycan əhalisində xüsusi etibarlılıq yoxlanışı aparılmamışdır – nəticələr klinik kontekstdə şərh edilməlidir.

Diaqnostik şərh

DDHP-nin DSM-5-TR meyarlarına uyğun təzahür forması:

- Əsasən diqqətsiz: Yalnız diqqətsizlik subskalası müsbət;
- Əsasən hiperaktiv-impulsiv: Yalnız hiperaktivlik subskalası müsbət;
- Kombinə edilmiş: Hər iki subskala müsbət.

Opozisiyon-etiraz subskalası ilə müsbət nəticə – komorbid opozisiyon-etiraz pozuntusunun (MİP, XBT-11 6C90) ehtimalını göstərir.

Qeyd: SNAP-IV – tədqiqat və klinik istifadə üçün sərbəst əlçatandır. Tam 90 suallı versiya, qısa 26 suallı versiya və müəllim versiyaları prof. Swansonun rəsmi saytından yüklənə bilər: SNAP-IV-ün rəsmi mənbəyinə dəqiq keçid verilməlidir (məsələn, müəllifin rəsmi səhifəsi)

B.5. İntellektual və adaptiv qiymətləndirmənin əsas alətləri (məlumat cədvəli)

Aşağıdakı vasitələr lisenziyalı psixoloji alətlərdir və mətndə tam verilə bilməz. Onların əldə edilməsi və istifadəsi üçün klinik psixoloq və ya ixtisaslı mütəxəssis lazımdır.

B.5.1. İntellektual qiymətləndirmə

Alət	Yaş qrupu	Naşir	Tipik vaxt
WPPSI-IV (ing. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)	2 il 6 ay – 7 il 7 ay	Pearson	60–90 dəq
WISC-V (ing. Wechsler Intelligence Scale for Children)	6–16 yaş	Pearson	60–90 dəq
WAIS-IV/V (ing. Wechsler Adult Intelligence Scale)	16–90 yaş	Pearson	60–90 dəq
Stanford-Binet 5	2 yaş+	Riverside Insights	45–75 dəq
Leiter-3 (qeyri-verbal)	3–75+ yaş	Stoelting	25–40 dəq
Ravenin Proqressiv Matrisləri (ing. Raven's Progressive Matrices)	5 yaş+	Pearson	20–40 dəq

B.5.2. Adaptiv davranış

Alət	Yaş qrupu	Naşir	Qiymətləndirmə növü
Vineland-3 (ing. Vineland Adaptive Behavior Scales)	Doğuşdan 90 yaşadək	Pearson	Valideyn/qəyyum ilə yarı strukturlaşdırılmış müsahibə
ABAS-3 (ing. Adaptive Behavior Assessment System)	Doğuşdan 89 yaşadək	WPS	Valideyn/müəllim qiymətləndirmə forması

B.5.3. Autizm diaqnostik alətləri

Alət	Yaş qrupu	Naşir	Tipik vaxt
ADOS-2 (ing. Autism Diagnostic Observation Schedule)	12 aydan böyüklərə qədər	WPS	40–60 dəq (5 modul)
ADI-R (ing. Autism Diagnostic Interview, Revised)	2 yaşdan böyüklərə qədər	WPS	90–150 dəq
CARS-2 (ing. Childhood Autism Rating Scale)	2 yaş+	WPS	15–30 dəq
SRS-2 (ing. Social Responsiveness Scale)	2,5 yaş və yuxarı	WPS	15–20 dəq

B.5.4. DDHP ətraflı qiymətləndirmə

Alət	Yaş qrupu	Naşir
Conners-3 (ing. Conners Rating Scales)	6–18 yaş	MHS
Conners CBRS	6–18 yaş	MHS
CAARS (ing. Conners Adult ADHD Rating Scales)	18+ yaş	MHS
BRIEF-2 (ing. Behavior Rating Inventory of Executive Function)	5–18 yaş	PAR
CPT-3 (ing. Conners Continuous Performance Test)	8 yaş+	MHS

Müəllifin qeydi

Əlavə B-də təqdim edilən skrininq şkalaları (M-CHAT-R, AQ-10, ASRS v1.1, SNAP-IV) klinik işdə birbaşa istifadə üçün hazırdır. Bu şkalaların müəlliflərinə və onların qurumlarına — Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına, Harvard Tibb Məktəbinə, professor Simon Baron-Cohen və əməkdaşlarına, Diana Robins, Deborah Fein, Marianne Barton və James Swansona — müasir psixiatriyaya böyük töhfələrinə görə təşəkkür edirik.

Lisenziyalı diaqnostik alətlər (ADOS-2, WISC-V, Vineland-3 və başqaları) bu kitabda tam təqdim edilə bilmir. Onların tətbiqi xüsusi təlim və rəsmi alınmış lisenziya tələb edir. Klinik mütəxəssislər bu alətləri birbaşa səlahiyyətli naşirlərdən (Pearson, WPS, MHS və ya ölkədəki rəsmi paylayıcılardan) əldə etməlidirlər.

Tərcümə və yerli etibarlılıq yoxlanışı haqqında qeyd. Bu kitabda təqdim olunan Azərbaycan dilinə tərcümələr klinik istifadə üçün işlək versiyalardır. Onlar Azərbaycan əhalisi üçün hələ formal psixometrik etibarlılıq yoxlanışından keçməmişdir. Elmi nəşrlərdə və etibarlılıq yoxlanışı tədqiqatlarında istifadə üçün rəsmi naşirlərdən təsdiqlənmiş tərcümələr alınmalıdır. Azərbaycan əhalisi üçün normativ göstəricilərin hazırlanması gələcək işin mühüm prioriteti hesab edilməlidir.

ƏLAVƏ C

PSİXİATRİK TƏCİLİ VƏZİYYƏTLƏR

Təcili vəziyyətdə vaxt yoxdur: qərar dəqiqələrlə ölçülür və çox vaxt natamam məlumat üzərində qurulur. Bu əlavə məhz belə anlar üçündür — nə edilməli olduğunu xatırladan qısa siyahılar, uzun mühakimə deyil. Siyahılar klinik düşüncəni əvəz etmir; onlar tez unudula bilən addımların qarşısını alır.

C.1. Aktiv intihar (suisid) riski

İntihar riskinin qiymətləndirilməsi anket deyil, söhbətdir. Sual birbaşa verilməlidir — bu, fikri «təlqin etmir»; əksinə, pasiyentə çox vaxt ilk dəfə açıq danışmağa imkan verir. Diqqət yetirilməli əsas məqam niyyətin nə dərəcədə konkret olmasıdır.

İlkin qiymətləndirmə:

- İntihar düşüncəsi var mı? Plan? Vasitə?
- Planın konkretliyi: pasiyent vaxtı, yeri və vasitəni adlandırırsa, risk kəskin artır; «bəzən ölmək istəyirəm» kimi ümumi ifadə isə başqa səviyyəyə aiddir;
- Əvvəlki cəhdlər — ən güclü proqnozlaşdırıcı amil;
- Maddə intoksikasiyası — inhibisiya azalır;
- Protektiv faktorlar — ailə, dini inanclar, gələcək planlar.

Yüksək risk əlamətləri:

- Konkret plan və vasitəyə asan əlçatanlıq;
- Son dövrdə baş verən həyat dəyişikliyi (itki, ağır xəstəlik);
- Təklik və xronik ağrı;
- Psixoz və ya ağır depressiya;
- Depressiyadan çıxışın erkən mərhələsi — enerji bərpa olunur, əhval isə hələ aşağıdır;
- Yetkin kişi, əlillik, alkoqol.

İdarəetmə:

Aşağı və orta risk:

- Təhlükəsizlik planı — yazılı;

- Vasitələrə çatımlılığın azaldılması (silahın uzaqlaşdırılması, dərman kiçik miqdarlarda);
- Yaxından ambulator izləmə (24–48 saat ərzində təkrar görüş);
- Böhran xəttinin nömrəsi;
- Ailə iştirakı (razılıqla).

Yüksək risk:

- Hospitalizasiya (könüllü və ya məcburi);
- Risk çox yüksəkdirsə — 1:1 nəzarət;
- Təhlükəli vasitələrin aradan qaldırılması (kəsici əşyalar, ip, pəncərəyə çıxış);
- Nəzarətli dərman qəbulu.

Azərbaycanda məcburi hospitalizasiya:

- «Psixiatrik yardım haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
- Məcburi hospitalizasiya üçün iki psixiatrın qərarı və hüquqi prosedur;
- 72 saatlıq təcili müşahidədən sonra məhkəmə qərarı.

C.2. Delirium tremens və alkoqol çəkilmə sindromu

Simptomlar:

- Tremor — əllər, sonra ümumi;
- Təşviş, ajitasiya;
- Hallüsinasiyalar — görmə və toxunma («dərimin üstündə həşəratlar»);
- Dezorientasiya;
- Vegetativ hiperaktivlik — taxikardiya, arterial təzyiqin artması, tərləmə, qızdırma;
- Qıcolmalar (təxminən 5–10%).

Müalicə (ICU və ya IMU şəraitində):

- Benzodiazepin — diazepam 10–20 mq venadaxili/əzələdaxili, hər 15–20 dəqiqədə sedasiya əldə olunana qədər; sonra saxlayıcı rejim;
- Alternativ: lorazepam (qaraciyər disfunksiyası olanlarda);
- Tiamin 100-300 mq IV — Vernike ensefalopatiyasının qarşısının alınması. Qlükoza verilməsindən əvvəl tətbiq edilməlidir.
- Maye və elektrolit bərpası;

- Maqnezium sulfatı və kalium — çox vaxt aşağı səviyyədədir;
- Letalitet: stasionar müalicə almış pasiyentlərdə təxminən 1–4%; müalicə olunmamış tarixi seriyalarda xeyli yüksəkdir.

Monitorinq üçün CIWA-Ar şkalası istifadə edilir.

C.3. Serotonin sindromu

Səbəb: SSGİ + MAOİ, SSGİ + triptan, SSGİ + tramadol, SSGİ + linezolid, SSGİ + metilen mavisi və s.

Simptomlar:

- Psixi dəyişiklik — aqitasiya, konfüziya;
- Vegetativ — taxikardiya, arterial təzyiqin artması, hipertermiya, tərləmə;
- Neyromuskulyar — tremor, hiperrefleksiya, klonus (xüsusilə aşağı ətraflarda — səciyyəvi əlamət).

Müalicə:

- Törədici dərmanın dərhal kəsilməsi;
- Dəstəkləyici müalicə — mayelər, elektrolitlər, soyutma;
- Ağır hallarda siproheptadin 12 mq ilkin doza, sonra hər 2 saatdan bir 2 mq maksimum 32 mq/gün;
- İnvaziv müdaxilə (intubasiya) ağır hipertermiyada.

C.4. Neyroleptik malign sindrom (NMS)

Səbəb: antipsixotiklər (xüsusilə yüksək potensiyalı antipsikotiklər (xüsusilə haloperidol)), kəskin başlanğıc və ya dozanın artırılması.

Simptomlar (4 əsas):

1. Əzələ sərtliyi («qurğuşun boru» tipli);
2. Hipertermiya (38–42°C);
3. Vegetativ qeyri-sabitlik (arterial təzyiqin artması, taxikardiya, tərləmə);
4. Psixi vəziyyət dəyişikliyi (konfüziya → stupor → koma).

Laboratoriya: kreatinfosfokinaza (CPK) kəskin yüksəlmiş (>1000 U/L), mioglobinuriya, leykositoz, ALT/AST yüksək.

Müalicə (reanimasiya şöbəsində):

- Antipsikotikin dərhal kəsilməsi;
- Soyutma;
- Mayelər (rabdomioliz və akut böyrək çatışmazlığı riski);
- Dantrolen 1–2,5 mq/kq venadaxili — əzələ sərtliyini azaldır;
- Bromokriptin 2,5–5 mq hər 8 saat — dopamin agonisti;
- Cavabsız hallarda EKT.

Letalitet: 5–20%; erkən tanınma və vaxtında müalicə ilə xeyli aşağı.

C.5. Kəskin distoniya

Səbəb: antipsixotik başlanğıcı, xüsusilə güclü D2 antaqonistləri.

Simptomlar:

- Kəskin əzələ spazmları — boyun (tortikolis), dil, göz (okulogirik kriz), qida borusu spazmı;
- Həyat təhlükəsi – laringeal spazm.

Müalicə:

- Difenhidramin 50 mq əzələ daxilinə və ya vena daxilinə — 15 dəqiqə ərzində rahatlama baş verir;
- Benztropin 1–2 mq əzələdaxili/venadaxili;
- Antipsikotikin dozasının azaldılması və ya dəyişdirilməsi;
- Yüksək riskli pasiyentlərdə profilaktik antikolinergik təyin edilir.

C.6. Kəskin maniya və psixomotor ajitasiya

İdarəetmə:

- Üstünlük peroral yola verilir: haloperidol 2–5 mq + lorazepam 1–2 mq;

- Göstəriş olduqda əzələ daxilinə: haloperidol 5 mq + lorazepam 2 mq (50/50 şpris) və ya olanzapin əzələdaxili 10 mq;

- Təhlükəsiz mühit — sakit, stimullardan azad;
- Şifahi deeskalasiya ilk addımdır;
- Dərman müalicəsi:

- Məcburi hospitalizasiya göstəriş olduqda;
- Fiziki məhdudlaşdırma — yalnız son çarə, həyat təhlükəsi olduqda və qısamüddətli.

C.7. Kəskin psixoz

Yuxarıdakı protokolla eyni qaydada tətbiq edilir. Differensial: üzvi səbəblər, maddə intoksikasiyası, doğuşdan sonrakı psixoz, NMS.

C.8. Katatoniya

Simptomlar:

- Stupor, mutizm;
- Katalepsiya («mum elastikliyi»);
- Negativizm;
- Manerizmlər, stereotiplər;
- Exolaliya, exopraksiya.

Birinci xətt müalicəsi:

- Lorazepam 1–2 mq venadaxili/əzələdaxili sınaq dozası — 1-2 saat ərzində əhəmiyyətli cavab → katatoniya diaqnozu və müalicə;
- Cavab alınarsa — doza 4–24 mq/günə çıxarılır;
- Cavab olmadıqda — EKT ikinci xətt müalicəsi kimi tətbiq edilir;
- Antipsikotikdən qaçınmaq kəskin fazada – NMS-i provokasiya edə bilər.

Səbəblər araşdırılmalıdır: üzvi (ensefalit, epilepsiya), əhval pozuntusu, şizofreniya, autizm, bəzi maddələr.

ƏLAVƏ D

HƏRBİ-TİBBİ EKSPERTİZA (AZƏRBAYCANDA)

Bu əlavə Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə yararlılıq qiymətləndirilməsi üçün psixiatrik aspektlərə dair praktik təlimat təqdim edir.

D.1. Hüquqi əsas

- «Hərbi xidmətə çağırış haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu;
- «Hərbi-tibbi ekspertiza haqqında Əsasnamə»;
- Müdafiə Nazirliyinin normativ aktları;
- Xəstəliklərin cədvəli — pozuntunun dərəcəsinə (yüngül/ağır) və A, B, V, Q qruplarına görə bölünür.

D.2. Psixiatrik qiymətləndirmə strukturu

Əsas ekspertiza:

- Şikayətlər və tarixçə (pasiyent və yaxın qohumları);
- Əvvəlki tibbi sənədlər;
- Klinik müsahibə və psixi statusun müayinəsi;
- Eksperimental-psixoloji müayinə (EPM) — psixoloq tərəfindən;
- Laboratoriya və instrumental müayinələr lazım olduqda;
- Differensial diaqnoz, əsas diaqnoz və xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi;
- Nəticə.

Tipik psixoloji testlər (EPM):

- MMPI-2 (Minnesota Çoxfazalı Şəxsiyyət İnventarı-2) — şəxsiyyət profili;
- Raven proqressiv matrisləri — intellekt;
- Luriya testləri — yaddaş, diqqət;
- Weksler intellekt şkalası (WAIS);
- Rorşax testi — proyektiv metod (müasir etibarlılığı mübahisəlidir);
- Beck, Hamilton şkalaları — əhval.

D.3. Psixiatrik pozuntular və hərbi xidmətə yararlılıq qiymətləndirilməsi

Qrupa görə təsnif (adaptasiya — yerli normativ aktlar əsasında):

A qrupu – xidmətə tam yararlı

Psixiatrik tarixçə yoxdur və ya cüzi keçici məsələlər.

B qrupu – məhdudiyyətlə yararlı

- Yüngül şəxsiyyət cizgiləri (pozuntu həddinə çatmayan);
- Müvəqqəti adaptasiya pozuntuları;
- Yüngül yuxu pozuntuları;
- Remissiya halında nevrotik pozuntular.

V qrupu — xidmət zamanı məhdud

- Qismən remissiya halında orta psixiatrik pozuntular;
- Müəyyən şəxsiyyət pozuntuları;
- Keçmiş PTSP, kompensasiya edilmiş;
- Orta dərəcədə neyrokognitiv disfunksiya.

Q qrupu – xidmətə yararsız

- Şizofreniya spektri;
- Bipolyar pozuntu;
- Ağır depressiya;
- Aktiv PTSP/kompleks PTSP (Qarabağ müharibəsi veteranları – ayrı müalicə proqramı);
- Maddə istifadəsi pozuntuları;
- Ağır şəxsiyyət pozuntuları;
- Mental gerilik;
- Autizm spektrinin ağır formaları;
- Aktiv intihar (suisid) riski olan pozuntular;
- Parafilik pozuntular (ağır, aktiv).

D.4. Veteranların qiymətləndirilməsi və döyüş travması

Qarabağ müharibəsi veteranlarında:

- Kompleks PTSP yüksək yayılma göstərir — travmaya yönəldilmiş müdaxilə tələb olunur;
- Alkoqol və maddə istifadəsi komorbiddir;
- Depressiya, intihar riski;
- Ailə funksiyasının pozulması;
- Mənəvi zərər — döyüş zamanı etik konflikt (öldürmə, şahid olmaq);
- Tükənmə və retravmatizasiya risk faktorları.

Xüsusi reabilitasiya proqramları:

- Sübuta əsaslanan, travmaya yönəldilmiş terapiya (PE, CPT, EMDR);
- Veteranlar üçün qrup terapiyası;
- Ailə terapiyası;
- Dərman müalicəsi (SSGİ/SNGİ);
- Sosial reabilitasiya (iş, təhsil).

ƏLAVƏ E

ƏLAQƏLİ NEVROLOJİ VƏZİYYƏTLƏR

Psixiatriya və neyrologiyanın kəsişdiyi sahələrdə klinik praktika üçün vacib olan nevroloji xəstəliklərin qısa təsviri verilir.

E.1. Epilepsiya (8A60–8A6Z) və psixiatrik təzahürlər

Epileptik sindromlar və psixiatriya:

İnteriktal şəxsiyyət dəyişiklikləri (Geşvind sindromu – hiperreligiozluq, hipergrafiya, «viskozlıq»);

- İnter-ikt psixoz – uzunmüddətli TLE;
- Post-ikt psixoz – tutkadan sonra 24–72 saat ərzində psixotik epizodlar;
- İktal təşviş və dissosiativ təzahürlər;

- Temporal lob epilepsiyası (TLE) — ən çox psixiatrik komorbidlik:
- Absans epilepsiyası — diqqət problemi, DDHP ilə differensial;
- Yeniyetmə miyoklonik epilepsiya — yüksək komorbid təşviş, impulsivlik.

Psikogen (qeyri-epileptik) tutmalar (PNES) – dissosiativ nevroloji simptom pozuntusu (6B60.4):

- Video-EEQ — qızıl standart differensial;
- PNES — epilepsiya ilə tez-tez komorbid, 10–30%;
- Müalicə: KDT-PNES, antiepileptik dərmanların tədricən azaldılması.

Antiepileptiklərin psixiatrik yan təsirləri:

- Levetirasetam: aqressiya, qıcıqlılıq, depressiya;
- Fenobarbital, primidon: depressiya, koqnitiv yavaşlama;
- Topiramat: koqnitiv disfunksiya, depressiya;
- Lamotrigin: əhvalı stabilləşdirir.

E.2. Baş ağrısı və psixiatrik komorbidlik

- Migren — depressiya riski 2–4 dəfə yüksəkdir; təşviş pozuntuları;

- Klaster baş ağrısı — depressiya, intihar (suisid) riski;
- Xronik gündəlik baş ağrısı — analgetiklərin həddindən artıq istifadəsi (MOH) – əhval pozuntusu ilə komorbidlik tez-tez müşahidə olunur;
- Təkrar gərginlik tipli baş ağrısı — sıx stress, təşviş ilə əlaqəli.

İdarəetmə:

- SSGİ/SNGİ bir çox baş ağrısı tipini yaxşılaşdırır;
- Trisiklik antidepresanlar (TCA, amitriptilin) migrenin profilaktikası üçün ənənəvi standartdır;
- Topiramat, valproat profilaktik;
- KDT xronik baş ağrısında effektivdir;
- Opioidlərdən və analgetiklərin həddindən artıq istifadəsindən çəkinmək lazımdır.

E.3. Beyin-qan damar xəstəlikləri (insult)

- İnsultdan sonrakı depressiya: ilk ildə 30–40%;
- İnsultdan sonrakı maniya: nadir, sağ frontal və ya talamik zədələrdə;
- Pseudobulbar affekt (patoloji gülmə/ağlama): dekstrometorfan-kinidin kombinasiyası sübuta əsaslanan müalicədir;
- Vaskulyar koqnitiv pozuntu/demensiya: 6D81 kodu altında təsnif edilir;
- Reabilitasiya: multidissiplinar, psixiatrik dəstək mərkəzi rolunda.

E.4. Parkinson xəstəliyi

- Depressiya: 30-50%;
- Təşviş: 30-40%;
- Dopamin agonistləri ilə induksiya olunan impuls nəzarəti pozuntusu: 13–36%;
- Parkinsonda psixoz: əsasən görmə hallüsinasiyaları; levodopa ilə induksiya olunur; levodopa-induksiya;
- Parkinsonda demensiya: 6D85;
- REM yuxu davranış pozuntusu: Parkinson xəstəliyi üçün erkən markerdir.

Müalicə xüsusiyyətləri:

- Antipsikotiklərin Parkinson xəstəliyində istifadəsi: kvetiapin, klozapin (D2 minimal blokada);

- Haloperidol, risperidon — motor simptomları pisləşdirir;
- SSGİ depressiya üçün;
- Pimavanserin — ABŞ-da Parkinson psixozu üçün təsdiq edilmişdir.

E.5. Multipl skleroz (MS)

- Depressiya: 30-50%;
- Təşviş: 30%;
- Bipolyar bənzər simptomlar: 5-10%;
- Pseudobulbar affekt;
- Koqnitiv disfunksiya — xəstəliyin çoxunda;
- Uyuşuqluq və yorğunluq — depressiya ilə sıx bağlıdır, differensial diaqnoz çətindir.

İnterferon-beta terapiyası depressiyanı pisləşdirir — aktiv monitorinq tələb olunur.

E.6. Travmatik beyin zədəsi (TBZ)

- Post-konkussion sindromu: baş ağrısı, baş gicəllənməsi, yaddaş problemi, əhval dəyişikliyi;
- Xronik travmatik ensefalopatiya (CTE): təkrar zədələr, idman (boks, Amerika futbolu);
- PTSP + TBZ — çox tez-tez komorbid;
- Şəxsiyyət dəyişikliyi (6E68) — frontal zədələrdə.

E.7. Demensiya (ətraflı Bölmə 17-də)

- 6D80 Alzheimer;
- 6D81 Vaskulyar;
- 6D82 Lewy cisimcik;
- 6D83 Frontotemporal;
- 6D84 Maddə-əlaqəli;
- 6D85 Parkinson ilə;
- 6D86 Demensiyada davranış və psixoloji pozuntular (BPSD).

E.8. Tutmalar, hərəkət pozuntuları və psixiatriya

- Turret sindromu (8A05.00) — XBT-11-də neyroloji xəstəliklər fəslində, lakin DDHP və obsesif-kompulsiv pozuntu (OKP) ilə komorbidliyi çox yüksəkdir;
- Vilson xəstəliyi — mis metabolizmasının genetik pozuntusu; psixiatrik təzahür (depressiya, psixoz) tez-tez; yoxlanması – seruloplazmin, 24-saatlıq sidik mis;
- Hantinqton xəstəliyi — əhval pozuntuları, OKP, psixoz, motor xoreya.

ÜMUMİ MƏNBƏLƏR VƏ ƏDƏBİYYAT

Əsas XBT-11 və DSM-5 mənbələri

1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). XBT-11 Psixi, Davranış və Neyroinkişaf Pozuntuları üçün Klinik Təsvirlər və Diaqnostik Tələblər (KTTD). Cenevrə: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST); 2024. ISBN: 9789240077263.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Psixi Pozuntuların Diaqnostik və Statistik Təsnifatı, 5-ci nəşr, Mətn Yenidən İşlənmiş (DSM-5-TR). APA Nəşriyyatı; 2022.
3. First M.B., Rid Q.M., Hayman S.E., Saksena S. Psixi və Davranış Pozuntuları üçün XBT-11 Klinik Təsvirləri və Diaqnostik Təlimatlarının hazırlanması. «Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry). 2015;14:82–90.
4. Rid Q.M. və b. Psixi, davranış və neyroinkişaf pozuntularının XBT-11 təsnifatında yeniliklər və dəyişikliklər. «Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry). 2019;18:3–19.

Klinik psixiatriya dərslikləri

1. Popov Yu.V., Vid V.D. Müasir klinik psixiatriya. 2-ci nəşr. Sankt-Peterburq: Reç; 2006.
2. Sadok B.C., Sadok V.A., Ruiz P. Kaplan və Sadokun Psixiatriya üzrə Hərtərəfli Dərsliyi. 11-ci nəşr. Volters Kluver; 2023.
3. Qelder M.Q., Andreasen N.K., Lopez-İbor C.C., Geddes C.R. (red.). Yeni Oksford Psixiatriya Dərsliyi. 3-cü nəşr. Oksford Universiteti Nəşriyyatı; 2020.
4. Koven P., Harrison P., Berns T. Qısa Oksford Psixiatriya Dərsliyi. 7-ci nəşr. Oksford Universiteti Nəşriyyatı; 2018.

Azərbaycan dilində mənbələr

1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. «Psixi xəstələrin müayinəsi və müalicəsinin sərəncamı» üzrə normativ sənədlər.
2. «Psixiatrik yardım haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu (2001, dəyişikliklərlə).

Praktik klinik qaydalar (guidelines)

1. Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik İnstitutu (NICE). Klinik qaydalar — psixiatrik şərtlər üzrə: CG31 Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP), CG78 Sərhəd şəxsiyyət pozuntusu (ŞPP), CG90 Depressiya, CG113 Ümumiləşmiş təşviş pozuntusu (ÜTP), CG115 Alkoqol, CG158 Davranış pozuntuları, NG69 Qida qəbulu pozuntuları, NG116 Travma sonrası stres pozuntusu (PTSD), CG111 Enurez.
2. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA). Praktik klinik qaydalar – şizofreniya, sərhəd şəxsiyyət pozuntusu (ŞPP), böyük depressiv pozuntu (TDP), yemə pozuntuları, Altsheymer xəstəliyi.
3. Ümumdünya Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyası (WFSBP). Klinik qaydalar – bipolyar pozuntu, şizofreniya, obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP), travma sonrası stres pozuntusu (PTSP), parafilik pozuntular.
4. Beynəlxalq Travmatik Stres Tədqiqatları Cəmiyyəti (ISTSS). Travma sonrası stres pozuntusunun profilaktikası və müalicəsi üzrə klinik qaydalar. 3-cü nəşr. 2019.
5. Kanada Əhval və Təşviş Pozuntuları Şəbəkəsi (CANMAT) / Beynəlxalq Bipolyar Pozuntular Cəmiyyəti (ISBD). Əhval və təşviş pozuntularının müalicəsi üzrə Kanada şəbəkəsi və bipolyar pozuntuların müalicəsi üzrə beynəlxalq cəmiyyətin klinik qaydaları. 2018, 2023.
6. Amerika Uşaq və Yeniyetmə Psixiatriyası Akademiyası (AACAP). Praktik parametrlər – uşaq və yeniyetmə psixiatrik pozuntuları.

Əsas resenzə olunan (peer-review) jurnallar

1. *«Amerika Psixiatriya Jurnalı» (American Journal of Psychiatry) — Amerika Psixiatriya Assosiasiyası (APA).*
2. *«Dünya Psixiatriyası» (World Psychiatry) — Ümumdünya Psixiatriya Assosiasiyası (WPA).*
3. *«Lancet Psixiatriyası» (Lancet Psychiatry).*
4. *«JAMA Psixiatriyası» (JAMA Psychiatry).*
5. *«Britaniya Psixiatriya Jurnalı» (British Journal of Psychiatry).*
6. *«Psixoloji Tibb» (Psychological Medicine).*
7. *«Klinik Psixiatriya Jurnalı» (Journal of Clinical Psychiatry).*
8. *«Avropa Psixiatriyası» (European Psychiatry).*

Onlayn resurslar

1. Beynəlxalq Xəstəliklərin Təsnifatı, 11-ci nəşri (XBT-11): https://icd.who.int
2. Massacusets Ümumi Xəstəxanasının Qadın Ruhi Sağlamlığı Mərkəzi (ing. MGH Center for Women's Mental Health): https://womensmentalhealth.org
3. Kokran Kitabxanası (ing. Cochrane Library): psixiatrik sistematik nəzərdən keçirmələr
4. «UpToDate Psixiatriya» (UpToDate Psychiatry) — klinik istinad resursu
5. «Psixiatriya Onlayn» (Psychiatry Online), Amerika Psixiatriya Assosiasiyasının nəşri (ing. APA Publishing) — dərsliklər, qaydalar
6. «Kolumbiya İntihar Şiddəti Şkalası» (Columbia Suicide Severity Rating Scale): https://cssrs.columbia.edu

---

Kənan Rəhimov

Bakı, 2026

ragimoff.org

YEKUN TÖVSIYƏLƏR

Klinik mütəxəssislər üçün praktiki xülasə

Kitabın bütün fəsillərindən əldə edilən əsas klinik dərslər:

Diaqnoz həmişə ikinci addımdır, birinci deyil

Psixi pozuntu diaqnozu qoymadan əvvəl mütləq:

- Tibbi səbəbləri istisna edin — xüsusilə 40–50 yaşdan sonra yeni başlanğıc, kəskin başlanğıc, atipik gedişat, somatik simptomlar, hormonal dövr dəyişiklikləri;
- Maddə istifadəsini yoxlayın — halların 30%-də gizli maddə komponenti;
- Travma tarixçəsini açıq soruşun — kompleks PTSP və şəxsiyyət pozuntuları tez-tez travmanın nəticəsidir, lakin travma tarixçəsi skrininq aparılmadan aşkar olunmur.

XBT-11 «primary vs secondary» prinsipi – klinikçi üçün əsas çərçivədir.

Psixoterapiya əksər hallarda birinci seçimdir

XBT-11 dövrünün mərkəzi mesajı: psixoterapiyanın effektivliyi təsdiqlənmişdir, farmakoterapiyadan ən az eyni dərəcədə, bir çox pozuntuda daha üstün:

- Yüngül-orta depressiyada — KDT, İPT SSGİ qədər effektivdir;
- Təşviş pozuntularında — KDT 1-ci sıra;
- OKP-də ekspozisiya (məruz qalma) və reaksiyanın qarşısının alınması (ERP) metodu mütləqdir; SSGİ əlavə edilir;
- PTSP-də — TF-KDT, EMDR 1-ci sıra;
- Şəxsiyyət pozuntularında dialektik davranış terapiyası (DBT), mentalizasiyaya əsaslanan terapiya (MBT) və transferensiyaya yönəlmiş psixoterapiya (TFP) farmakoterapiyadan daha effektivdir;
- Qida qəbulu pozuntularında — KDT-E, FBT;
- Uşaq davranış pozuntularında — valideyn təhsil proqramları.

Farmakoterapiya çox hallarda köməkçi vasitədir — o, psixoterapiyanın effektivliyini artırmağa və nəticəni saxlamağa kömək edir.

Minimum effektiv doza prinsipi

- Başlanğıc doza aşağı olmalı, doza tədricən artırılmalıdır;
- Qəti minimum effektiv dozaya çatana qədər artırılmalıdır;
- Polidərmandan (polifarmasiyadan) çəkinin — yaşlılarda, komorbidlikdə, şəxsiyyət pozuntularında xüsusilə;
- Dərmanın kəsilməsi və ya azaldılması da bilik tələb edir – SSGİ-ni birdən kəsmək olmaz, benzodiazepinlər tədricən azaldılmalıdır.

Mədəni kontekstlə iş

Azərbaycan kontekstində:

- Somatik təzahür çox yayılmışdır — ilkin səhiyyədə depressiya və təşviş üzrə aktiv skrininq tələb olunur;
- Damğalama və məxfilik — psixiatra müraciət gizlədilir; ilkin səhiyyə və ya daxili xəstəliklər həkimi səviyyəsində iş effektivdir;
- Ailə sistemi güclüdür — müalicədə ailənin iştirakı böyük imkandır;
- Din və mədəni inanclar — nəzərə alınmalı, lakin onlar patoloji məzmun kimi qiymətləndirilməməlidir;
- Qarabağ Müharibəsi veteranları — PTSP, kompleks PTSP (kPTSP) və travmaya yönəlmiş müdaxilələrə ehtiyac yüksəkdir.

Skrininq ilkin səhiyyədə standart olmalıdır

Əsas skrininq alətləri ilkin səhiyyədə mütəmadi tətbiq edilməlidir:

- PHQ-9 (Xəstə Sağlamlığı Sorğusu-9) — depressiya (hər tibbi ziyarətdə);
- ÜTP-7 — təşviş;
- AUDIT — alkogol istifadəsi;
- EPDS — perinatal qadınlar;
- C-SSRS — intihar (suisid) riski.

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və etibarlılığı yoxlanılmış alətlərə sərmayə qoyulmalıdır.

İntihar riskinin qiymətləndirilməsi

Hər psixiatrik görüşdə aktiv sorğu:

- Son vaxtlarda ölüm və ya öz həyatınıza son qoymaqla bağlı düşüncələr olubmu?
- Konkret planınız və ya vasitəniz var?
- Əvvəlki cəhdlər?

Risk faktorları:

- Əvvəlki cəhdlər (ən güclü proqnozlaşdırıcı amil);
- Ailədə intihar tarixi;
- Planın konkretliyi və yaxın dövrdə olması;
- Vasitələrin əlçatanlığı;
- Maddə istifadəsi, depressiya, ŞPP, psixoz;
- Kəskin stress amili, itki;

Müdaxilə:

- Təhlükəsizlik planı;
- Vasitələrə əlçatanlığın azaldılması;
- Yaxından izləmə;
- Göstəriş olduqda hospitalizasiya;
- C-SSRS kimi şkala ilə strukturlaşdırılmış qiymətləndirmə.

Komorbidlik qaydadır, istisna deyil

Psixi pozuntularda komorbidlik normadır:

- depressiya və təşviş — 60% hallarda komorbidlik müşahidə olunur;
- PTSP və depressiya — 50%-dən çox;
- Şəxsiyyət pozuntusu + depressiya, təşviş və maddə istifadəsi ilə birlikdə — 80%-dən çox;
- Autizm spektri pozuntusu və DDHP — 50%;
- Yemə və qidalanma pozuntusu + depressiya və psixi travma — tez-tez rast gələn kombinasiya.

Müalicə planı bütün komorbidlikləri əhatə etməlidir — əsas pozuntunun təkbaşına müalicəsi çox vaxt kifayət deyil.

Yaş və inkişaf mərhələsi nəzərə alınmalıdır

- Uşaqda psixi pozuntu — valideyn və mühit amili mühüm rol oynayır; dərman vasitələrindən az istifadə olunur, psixoterapiya və ailə-yönləndirmə

daha çox;

- Yeniyetmə — şəxsiyyət kimliyinin formalaşması, erkən müdaxilə həlledici əhəmiyyət daşıyır;
- Yetkinlik dövründə iş, ailə və sosial funksiya ön plana çıxır;
- Yaşlı — komorbid tibbi xəstəliklər, polifarmasiya, koqnitiv pozuntular; demensiya ilə depressiyaya xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Multidissiplinar komanda — effektiv klinik işin əsasıdır

Mürəkkəb hallarda:

- Psixiatr;
- Psixoloq/psixoterapevt;
- Sosial işçi;
- Tibb mütəxəssisi (komorbid xəstəliklər üzrə);
- Ailə üzvləri (xəstənin məlumatlı razılığı əsasında);
- Məktəb və iş yeri nümayəndələri (uşaq xəstələrdə).

Azərbaycanda bu strukturun inkişaf etdirilməsi — strateji prioritetdir.

Etik və hüquqi çərçivə

Hər həkim bilməlidir:

- Məxfilik və onun sərhədləri (başqalarına təhlükə, uşaq müdafiəsi);
- Məlumatlı razılıq;
- Məcburi hospitalizasiyanın hüquqi çərçivəsi;
- Uşaq / yaşlı;
- Məhkəmə-psixiatrik qiymətləndirmənin əsasları;
- Sənədləşmənin əhəmiyyəti.

Həkimin öz sağlamlığına diqqəti

Psixiatrik iş — emosional yükü yüksək peşədir. Peşəkar tükənmə (burnout), ikinci dərəcəli travma, empatik yorğunluq həkim üçün real risklərdir.

- Superviziya və kollegial konsultasiya;
- Şəxsi psixoterapiya;
- Sağlam həyat tərzi;

- Həddini bilmək — bütün xəstələri xilas etmək mümkün deyil.

Davamlı təhsil və inkişaf

XBT-11 onilliklər boyunca sabit qalacaq, lakin aşağıdakılar dəyişir:

- Müalicə standartları hər 3–5 ildə yenilənir;
- Yeni dərmanlar, yeni psixoterapevtik protokollar çıxır;
- AACAP, APA, NICE, WFSBP, ISTSS kimi təşkilatların rəhbər prinsiplərini müntəzəm izləmə;
- Resenziyalı jurnallar: Lancet Psychiatry, JAMA Psychiatry, American Journal of Psychiatry, World Psychiatry.

Kitabın məqsədi: Azərbaycanda psixiatrik yardımın keyfiyyətinə, xəstə və ailələrə, peşəkar inkişafa töhfə vermək. Oxucu bu kitabdan faydalandıqda, məqsədə nail olunmuş sayılacaq.

Sağlıqlı müalicə, peşəkar yüksəliş və xəstələrinizə faydalı olmaq diləyi ilə.

Kənan Rəhimov

Bakı, 2026